

KlinikIQ Genel Klinik Vakalar - Strict QC Refined Report

İşlem türü: Genel klinik vakalarda metin, jargon, vital, muayene, tetkik, seçenek ve feedback kalite sıkılaştırması.

Tarih: 27 Mayıs 2026

Metrik	Sonuç
Taranan genel klinik vaka	410
Güncellenen genel klinik vaka	410
ID / sıra değişikliği	Yok
6 alan vital standardizasyonu	289
Fizik muayene metni iyileştirme	74
Seçenek metni rewrite/polish	75
Feedback rewrite	2050
Rationale/core rewrite	410
Şablon feedback kalanı	0
Eksik/zayıf feedback kalanı	0
Section bypass	Yok
Kritik bilimsel uyarı	0

INDEX - Branşa Göre Dağılım

Branş	Vaka sayısı
anatomy	29
general-surgery	27
histology-embryology	28
internal-medicine	26
medical-biochemistry	30
medical-microbiology	30
medical-pathology	28
medical-pharmacology	28
minor-rotations	28
obstetrics-gynecology	28
pediatrics	98
physiology	30

Vaka ID listesi: v163-new-001-akut-sistemik-reaksiyon, v163-new-002-acil-elektrolit-bozuklugu, v163-new-003-atesli-dokuntulu-cocuk, v163-new-004-gebelikte-akut-karin, v163-new-005-ani-gelisen-noroljik-defisit, v163-new-006-sag-alt-kadran-agrisi, v163-new-007-kolinerjik-bulgularla-zehirlenme, v163-new-008-kronik-malabsorpsiyon-tablosu, v163-new-009-omuz-travmasi-sonrasi-guc-kaybi, v163-new-010-acilikla-belirginlesen-metabolik-tablo, v164-new-011-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma, v164-new-012-beslenme-sonrasi-kusan-bebek, v164-new-013-atesli-monoartrit, v164-new-014-purpura-ve-noroljik-bulgular, v164-new-015-dogum-sonrasi-izlem, v164-new-016-akut-skrotal-agri, v164-new-017-yeni-baslayan-temporal-bas-agrisi, v164-new-018-hemoptizi-ve-hematuri-birlikteligi, v164-new-019-ilac-sonrasi-ajitasyon-ve-ates, v164-new-020-antibiyotik-sonrasi-ishal, v165-new-021-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma, v165-new-022-erken-donemde-sarilik, v165-new-023-dogum-sonrasi-aktif-kanama, v165-new-024-ates-ve-yeni-ufurum, v165-new-025-yukselen-gucsuyluk-tablosu, v165-new-026-bradikardi-ve-hipotansiyon, v165-new-027-yuzde-sislik-ve-proteinuri, v165-new-028-boyun-cerrahisi-sonrasi-ses-degisikligi, v165-new-029-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon, v165-new-030-hipotansiyon-ve-elektrolit-bozuklugu, v166-new-031-gebelikte-kanama-sonrasi-degerlendirme, v166-new-032-ishal-sonrasi-bobrek-yetmezligi, v166-new-033-hiperglisemik-acil-tablo, v166-new-034-gun-icinde-artan-kas-gucsuylugu, v166-new-035-ates-ve-inspiratuvar-solum-sikintisi, v166-new-036-ates-ve-yeni-ufurum, v166-new-037-pelvik-cerrahide-riskli-yapi, v166-new-038-gorme-yakinmasi-ve-metabolik-asidoz, v166-new-039-trombositopeni-ve-noroljik-bulgu, v166-new-040-kronik-halsizlik-ve-hipotansiyon, v167-new-041-bilinc-degisikligi-ve-solum-baskilanmasi, v167-new-042-asidoz-ve-hiperglisemi-tablosu, v167-new-043-premature-bebekte-solum-sikintisi, v167-new-044-uzamis-ates-ve-ufurum, v167-new-045-yavas-ilerleyen-hareket-bozuklugu, v167-new-046-gebelikte-hipertansif-tablo, v167-new-047-ates-ve-sag-ust-kadran-agrisi, v167-new-048-hemoliz-ve-noroljik-bulgular, v167-new-049-kolik-yan-agrisi, v167-new-050-akut-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon, v168-new-051-omuz-hareketinde-postoperatif-gucluk, v168-new-052-bilinc-bulanikligi-ve-hiponatremi, v168-new-053-yenidoganda-santral-siyanoz, v168-new-054-tromboz-egilimi-olan-ergen, v168-new-055-yenidoganda-okuler-ve-noroljik-bulgular, v168-new-056-agrisiz-hematuri-ve-renal-kitle, v168-new-057-yeni-baslayan-kuru-oksruk, v168-new-058-hiperglisemi-ve-asidotik-solum, v168-new-059-ates-ve-sarilikla-basvuran-hasta, v168-new-060-agiz-yaralari-ve-gevsek-buller, v169-new-061-uzamis-ates-ve-mukokutanoz-bulgular, v169-new-062-gebelikte-hipertansiyon-ve-noroljik-yakinma, v169-new-063-trombositopeni-ve-noroljik-bulgu, v169-new-064-antibiyotik-sonrasi-ishal, v169-new-065-anestezi-sirasinda-ani-kriz, v169-new-066-eriskinde-nefrotik-tablo, v169-new-067-kalca-cerrahisi-sonrasi-yurume-bozuklugu, v169-new-068-kronik-dispne-ve-hava-hapsi, v169-new-069-protein-alimi-sonrasi-ensefalopati, v169-new-070-ani-goz-agrisi-ve-gorme-bulanikligi, v172-new-071-cocukta-agrisiz-alt-gastrointestinal-kanama, v172-new-072-direncli-hipertansiyon-ve-kas-gucsuylugu, v172-new-073-kirli-yara-sonrasi-kas-spazmlari, v172-new-074-siddetli-karin-agrisi-ve-atriyal-fibrilasyon, v172-new-075-servikal-lenf-nodu-ile-saptanan-tiroid-nodulu, v172-new-076-hiperurisemi-ve-davranissal-bulgular, v172-new-077-antikoagulan-tedavi-sirasinda-yeni-tromboz, v172-new-078-yenidoganda-hipokalsemik-nobet, v172-new-079-yanik-yarasinda-kotulesen-enfeksiyon,

v339-peds-005-viral-enfeksiyon-sonrasi-morarma, v339-peds-006-bebekte-tekrarlayan-agir-enfeksiyon, v339-peds-007-fotografta-beyaz-pupilla, v339-peds-008-kas-gucluclu-ve-goz-cevresinde-mor-dokuntu, v339-peds-009-yenidogan-taramasinda-metabolik-risk, v339-peds-010-erken-meme-gelisimi

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 1: v163-new-001-akut-sistemik-reaksiyon

Başlık: Akut sistemik reaksiyon

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Acil Tıp / İmmünoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Anafilaktik reaksiyonda ilk acil tedavi basamağını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, antibiyotik enjeksiyonundan kısa süre sonra gelişen nefes darlığı ve yaygın kaşıntı nedeniyle acil servise getiriliyor. Şikâyetlerin enjeksiyondan yaklaşık 10 dakika sonra başladığı, önce avuç içlerinde kaşıntı ve yüzde kızarma olduğu, ardından boğazda sıkışma hissi ve baş dönmesi geliştiği öğreniliyor. Bilinen astım öyküsü yoktur.

Demografi: 24 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 80/45 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,60 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta huzursuz ve soluk görünümündedir.
- Dudaklarda hafif ödem, yaygın ürtiker plakları ve bilateral yaygın hışıltı mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-248 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Dudaklarda hafif ödem, yaygın ürtiker plakları ve bilateral yaygın hışıltı mevcuttur. | Klinik anlam: İntramüsküler adrenalın uygulanması | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/248_swollen_lips_and_skin_rash_close_up.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/248_swollen_lips_and_skin_rash_close_up.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Dudaklarda hafif ödem, yaygın ürtiker plakları ve bilateral yaygın hışıltı mevcuttur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk uygulanması gereken acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz antihistaminik uygulanması
B) İnhalasyon kısa etkili beta-2 agonist verilmesi
C) İntramüsküler adrenalın uygulanması
D) İntravenöz kortikosteroid başlanması
E) Nebülize salbutamol sonrası antihistaminik-kortikosteroid yanıtına göre adrenalın kararını ertelemek

Doğru Cevap: İntramüsküler adrenalın uygulanması

A) İntravenöz antihistaminik uygulanması: İntravenöz antihistaminik kaşıntı ve ürtikeri azaltabilir ancak hipotansiyon ve bronkospazmı hızla düzelten hayat kurtarıcı ilk tedavi değildir. Bu olguda “Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) İnhalasyon kısa etkili beta-2 agonist verilmesi: İnhalasyon kısa etkili beta-2 agonist bronkospazma yardımcı olabilir fakat dolaşım kollapsı ve mukozal ödemi tek başına tedavi etmez. Bu olguda “Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) İntramüsküler adrenalın uygulanması: İntramüsküler adrenalın bu tabloda hava yolu ödemi, bronkospazmı ve vazodilatasyona bağlı hipotansiyonu aynı anda hedeflediği için ilk basamaktır. Vakadaki “Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

D) İntravenöz kortikosteroid başlanması: İntravenöz kortikosteroid geç etkili olduğu için akut hipotansiyon ve solunum sıkıntısında ilk hayat kurtarıcı tedavi değildir. Bu olguda “Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nebülize salbutamol sonrası antihistaminik-kortikosteroid yanıtına göre adrenalın kararını ertelemek: Vakadaki Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır ve Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür. Bu olguda “Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Akut sistemik reaksiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.” birlikte okunduğunda İntramüsküler adrenalın uygulanması seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon, hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşme acil hava yolu-dolaşım riski oluşturur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada ilaç uygulamasından dakikalar sonra gelişen yaygın ürtiker, hava yolu tutulumu, bronkospazm ve hipotansiyon yaşamı tehdit eden sistemik aşırı duyarlılık reaksiyonunu gösterir. İlk ve hayat kurtarıcı tedavi intramüsküler adrenalındır; antihistaminik, bronkodilatör ve kortikosteroidler ancak yardımcı tedavi olarak kullanılabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.”, “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.” ve “Hipotansiyon, hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşme acil hava yolu-dolaşım riski oluşturur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntramüsküler adrenalın uygulanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Antibiyotik enjeksiyonundan dakikalar sonra sistemik bulgular başlamıştır.

Kanıt 2: Yaygın ürtiker ve dudak ödemi mast hücre aracılı yaygın reaksiyonu düşündürür.

Kanıt 3: Hipotansiyon, hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşme acil hava yolu-dolaşım riski oluşturur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Sistemik alerjik reaksiyonda hipotansiyon veya solunum bulgusu varsa ilk tedavi intramüsküler adrenalındır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 2: v163-new-002-acil-elektrolit-bozuklugu

Başlık: Acil elektrolit bozukluğu

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Kardiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Akut hiperkalemiye elektrokardiyografik değişiklik varsa ilk tedaviyi belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, çarpıntı ve yaygın halsizlik nedeniyle acil servise başvuruyor. Son iki gündür iştahsızlık ve kas güçsüzlüğü tarifliyor.

Hipertansiyon nedeniyle anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü kullandığı ve son haftalarda kontrollerine gitmediği öğreniliyor.

Demografi: 68 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 145/85 mmHg | Nabız: 48/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,33

Fizik Muayene

- Genel durumu orta, bilinci açık ve oryantedir.
- Akciğer oskültasyonunda belirgin ral yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aritmi riski açısından kritik düzeydedir. | Sonuç yorumu: Aritmi riski açısından kritik düzeydedir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Aritmi riski açısından kritik düzeydedir. | Satırlar: Serum potasyum / 7.1 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Aritmi riski açısından kritik düzeydedir.

Tetkik 2: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: ecg | Alt tip: EKG | Özet: Sivri T dalgaları ve QRS komplekslerinde genişleme izleniyor. | Klinik anlam: Hücresel membran stabilitesinin bozulduğunu düşündürür. | Sonuç yorumu: Hücresel membran stabilitesinin bozulduğunu düşündürür. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Sivri T dalgaları ve QRS komplekslerinde genişleme izleniyor. | Yorum: Hücresel membran stabilitesinin bozulduğunu düşündürür. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Sivri T dalgaları ve QRS komplekslerinde genişleme izleniyor. / / Hücresel membran stabilitesinin bozulduğunu düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-001 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Sivri T dalgaları ve QRS komplekslerinde genişleme izleniyor. | Klinik anlam: Hücresel membran stabilitesinin bozulduğunu düşündürür. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/001_001-hiperkalemi-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/001_001-hiperkalemi-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Sivri T dalgaları ve QRS komplekslerinde genişleme izleniyor. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk uygulanması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi
B) İntravenöz insülin ve glukoz verilmesi
C) Nebülize salbutamol verilmesi
D) Potasyum bağlayıcı reçine başlanması
E) Hemodiyaliz planlanması

Doğru Cevap: İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi

A) İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi: İntravenöz kalsiyum glukonat EKG değişikliği olan ağır potasyum yükseklğinde miyokard membranını hızla stabilize ettiği için ilk tedavidir. Vakadaki "Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir." ve "Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) İntravenöz insülin ve glukoz verilmesi: İntravenöz insülin ve glukoz potasyumu hücre içine kaydırır ancak EKG değişikliği varken membran stabilizasyonundan sonra verilmelidir. Bu olguda "Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir." ve "Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Nebülize salbutamol verilmesi: Nebülize salbutamol potasyumu hücre içine kaydırmaya yardımcı olabilir fakat kardiyak membran stabilizasyonu sağlamaz. Bu olguda "Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir." ve "Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Potasyum bağlayıcı reçine başlanması: Potasyum bağlayıcı reçine yavaş etkili olduğundan akut EKG değişikliği olan hastada ilk müdahale için yetersizdir. Bu olguda "Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir." ve "Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Hemodiyaliz planlanması: Hemodiyaliz kalıcı potasyum uzaklaştırması sağlayabilir ancak akut kardiyak ileti riski varken ilk saniyelerde yapılması gereken işlem değildir. Bu olguda "Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir." ve "Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Acil elektrolit bozukluğu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir." ve "Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir." birlikte okunduğunda İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneği öne çıkar; "Bradikardi ve düzensiz nabız ritim bozukluğu riskini artırır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada ağır potasyum yükseklığıyle birlikte EKG değişiklikleri vardır. İlk amaç serum potasyumunu hemen düşürmekten önce miyokard hücre membranını stabilize etmektir; bu nedenle ilk tedavi intravenöz kalsiyum glukonattır. İnsülin-glukoz, beta-2 agonist veya diyaliz potasyumu azaltmaya yönelik sonraki basamaklardır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir.", "Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir." ve "Bradikardi ve düzensiz nabız ritim bozukluğu riskini artırır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Serum potasyum değeri kritik düzeyde yüksektir.

Kanıt 2: Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi kardiyak ileti etkilenmesini gösterir.

Kanıt 3: Bradikardi ve düzensiz nabız ritim bozukluğu riskini artırır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağı yerine geçmez.

Exam Pearl: Hiperkalemiye EKG değişikliği varsa ilk basamak potasyumu hücre içine sokmak değil, intravenöz kalsiyumla miyokardı stabilize etmektir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 3: v163-new-003-atesli-dokuntulu-cocuk

Başlık: Ateşli döküntülü çocuk

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Enfeksiyon Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik bağlam ve mikrobiyolojik ipuçlarıyla olası etkeni belirleme.

Learning Target: Purpura, ense sertliği ve şok bulgularıyla seyreden meningokoksemide en olası etkeni belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve bacaklarda hızla artan döküntü nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 12 saat önce ateş ve halsizlik başladığı, son birkaç saat içinde kusma ve ışığa hassasiyet geliştiği öğreniliyor. Aile, döküntülerin kısa sürede morumsu lekelerle dönüştüğünü belirtiyor.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 75/40 mmHg | Nabız: 145/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 39.5°C | Şok indeksi: 1,93 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta letarjik görünümündedir.
- Ense sertliği mevcuttur.
- Alt ekstremitelerde basmakla solmayan purpurik döküntüler izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lökositoz ve trombositopeni saptandı. | Klinik anlam: Ağır bakteriyel enfeksiyon ve sistemik inflamasyonla uyumludur. | Sonuç yorumu: Ağır bakteriyel enfeksiyon ve sistemik inflamasyonla uyumludur. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lökositoz ve trombositopeni saptandı. | Yorum: Ağır bakteriyel enfeksiyon ve sistemik inflamasyonla uyumludur. | Satırlar: Tam kan sayımı / 23.000 /mm³ / 4.500-11.000 /mm³ / Ağır bakteriyel enfeksiyon ve sistemik inflamasyonla uyumludur.

Tetkik 2: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama

Etiket: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Tip: microscopy | Alt tip: Mikroskopi | Özet: Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar görüldü. | Klinik anlam: Morfolojik etken ayrımı için belirleyicidir. | Sonuç yorumu: Morfolojik etken ayrımı için belirleyicidir. | Sonuç başlığı: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Sonuç özeti: Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar görüldü. | Yorum: Morfolojik etken ayrımı için belirleyicidir. | Satırlar: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama / Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar görüldü. / / Morfolojik etken ayrımı için belirleyicidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-002 | Başlık: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Modalite: microscopy | Bulgu: Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar görüldü. | Klinik anlam: Morfolojik etken ayrımı için belirleyicidir. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/002_002-gram-negatif-diplokok-gram-boyama.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/002_002-gram-negatif-diplokok-gram-boyama.webp | Alt text: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama - Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-249 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Alt ekstremitelerde basmakla solmayan purpurik döküntüler izlenir. | Klinik anlam: Neisseria meningitidis | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/249_rash_pattern_on_lower_legs_of_child.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/249_rash_pattern_on_lower_legs_of_child.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Alt ekstremitelerde basmakla solmayan purpurik döküntüler izlenir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Streptococcus pneumoniae
B) Neisseria meningitidis
C) Haemophilus influenzae tip b
D) Listeria monocytogenes
E) Staphylococcus aureus

Doğru Cevap: Neisseria meningitidis

A) Streptococcus pneumoniae: Streptococcus pneumoniae bakteriyel menenjit yapabilir ancak gram-pozitif diplokoktur ve purpurik septik tabloyla bu morfolojiye uymaz. Bu olguda “Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.” ve “Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.” ipuçları tanısalar karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Neisseria meningitidis: Neisseria meningitidis gram-negatif diplokok yapısı, purpurik döküntü ve hızlı gelişen septik şokla bu olguda en iyi uyum gösterir. Vakadaki “Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.” ve “Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

C) Haemophilus influenzae tip b: Haemophilus influenzae tip b menenjit etkeni olabilir ancak küçük gram-negatif kokobasil yapısındadır ve verilen Gram boyama sonucu ile örtüşmez. Bu olguda “Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.” ve “Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.” ipuçları tanısalar karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Listeria monocytogenes: Listeria monocytogenes özellikle yenidoğan, gebe ve yaşlılarda önemlidir; gram-pozitif basil olması bu Vakadaki mikroskobik bulguya uymaz. Bu olguda “Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.” ve “Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.” ipuçları tanısalar karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus gram-pozitif kok kümeleri oluşturur ve bu hastadaki intrasölüler gram-negatif diplokok bulgusunu açıklamaz. Bu olguda “Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.” ve “Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.” ipuçları tanısalar karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateşli döküntülü çocuk olgusunda klinik karar tanısalar karar üzerine kuruludur. “Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.” ve “Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.” birlikte okunduğunda Neisseria meningitidis seçeneği öne çıkar; “Nötrofiller içinde gram-negatif diplokok görülmesi etken morfolojisini daraltır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, ense sertliği, bilinç değişikliği, septik şok ve basmakla solmayan purpura invaziv meningokokal hastalık için tipiktir. Beyin omurilik sıvısında nötrofiller içinde gram-negatif diplokok görülmesi bu etkeni en olası seçenek haline getirir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.”, “Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.” ve “Nötrofiller içinde gram-negatif diplokok görülmesi etken morfolojisini daraltır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Neisseria meningitidis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yüksek ateş, ense sertliği ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyon düşündürür.

Kanıt 2: Basmakla solmayan purpurik döküntüler fulminan bakteriyemi ile uyumludur.

Kanıt 3: Nötrofiller içinde gram-negatif diplokok görülmesi etken morfolojisini daraltır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Çocukta ateş, meningismus, şok ve purpura birlikteliği meningokokal sepsisi düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 4: v163-new-004-gebelikte-akut-karın

Başlık: Gebelikte akut karın

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Ektopik gebelik şüphesinde hemodinamik instabilite varlığında uygun yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan alt karın ağrısı ve bayılma hissi nedeniyle acil servise getiriliyor. Son adet tarihine göre 7 haftalık gebelik olasılığı olduğunu, son iki gündür hafif vajinal lekelenme yaşadığını ve ağrının bugün sağ alt kadranda aniden şiddetlendiğini belirtiyor. Daha önce pelvik inflamatuvar hastalık nedeniyle tedavi aldığını ifade ediyor.

Demografi: 29 yaşında kadın hasta | Setting: Kadın hastalıkları ve doğum acili

Vital Bulgular

Kan basıncı: 80/50 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1.65 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve terli görünümündedir.
- Alt batında belirgin hassasiyet ve defans vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum beta-hCG

Etiket: Serum beta-hCG | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Gebelikle uyumlu pozitif sonuç saptandı. | Klinik anlam: Erken gebelik varlığını destekler. | Sonuç yorumu: Erken gebelik varlığını destekler. | Sonuç başlığı: Serum beta-hCG | Sonuç özeti: Gebelikle uyumlu pozitif sonuç saptandı. | Yorum: Erken gebelik varlığını destekler. | Satırlar: Serum beta-hCG / 5600 mIU/mL / / Erken gebelik varlığını destekler.

Tetkik 2: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: ultrasound | Alt tip: Ultrasonografi | Özet: Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; pelviste serbest sıvı mevcuttur. | Klinik anlam: Acil cerrahi karar açısından kritik bulgudur. | Sonuç yorumu: Acil cerrahi karar açısından kritik bulgudur. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; pelviste serbest sıvı mevcuttur. | Yorum: Acil cerrahi karar açısından kritik bulgudur. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; pelviste serbest sıvı mevcuttur. / / Acil cerrahi karar açısından kritik bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-003 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; pelviste serbest sıvı mevcuttur. | Klinik anlam: Acil cerrahi karar açısından kritik bulgudur. | URL: https://iukbtlkzixictqsds.public.blob.vercel-storage.com/003_003-pelvik-serbest-sivi-transvajinal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqsds.public.blob.vercel-storage.com/003_003-pelvik-serbest-sivi-transvajinal-ultrasonografi.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; pelviste serbest sıvı mevcuttur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Seri beta-hCG takibi ile ayaktan izlem
- B) Tek doz metotreksat tedavisi
- C) Progesteron düzeyi ölçümü sonrası karar verme
- D) Acil cerrahi eksplorasyon
- E) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi

Doğru Cevap: Acil cerrahi eksplorasyon

- A) Seri beta-hCG takibi ile ayaktan izlem: Seri beta-hCG takibi yalnızca stabil ve rüptür bulgusu olmayan hastalarda düşünülebilir; bu olguda şok bulguları vardır. Bu olguda “Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.” ve “Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Tek doz metotreksat tedavisi: Metotreksat stabil, seçilmiş ve rüptür bulgusu olmayan olgularda uygundur; periton bulgusu ve hipotansiyon varlığında güvenli değildir. Bu olguda “Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.” ve “Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Progesteron düzeyi ölçümü sonrası karar verme: Progesteron düzeyi tanısal belirsizliği azaltabilir ancak akut kanama ve instabilite varken tedaviyi geciktirmemelidir. Bu olguda “Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.” ve “Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Acil cerrahi eksplorasyon: Acil cerrahi eksplorasyon instabil, pelvik serbest sıvı ve periton irritasyonu olan gebelerde kanama kontrolü için en uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.” ve “Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- E) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi: Geniş spektrumlu antibiyotik pelvik enfeksiyon için gerekebilir ancak bu Vakadaki gebelik, serbest sıvı ve şok tablosunun definitive tedavisi değildir. Bu olguda “Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.” ve “Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte akut karın olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.” ve “Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.” birlikte okunduğunda Acil cerrahi eksplorasyon seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi gösterir.” ise ayrıncı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada erken gebelik, uterin kavitede kese izlenmemesi, pelvik serbest sıvı, periton irritasyonu ve hemodinamik instabilite rüptüre ekstrauterin gebelik olasılığını güçlendirir. Stabil olmayan hastada metotreksat veya seri takip uygun değildir; acil cerrahi eksplorasyon gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.”, “Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil cerrahi eksplorasyon en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Gebelik testi pozitifken uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemiştir.

Kanıt 2: Ani şiddetli alt karın ağrısı ve pelvik serbest sıvı intraabdominal kanama riskini düşündürür.

Kanıt 3: Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve

geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ektopik gebelik şüphesinde hemodinamik instabilite varsa medikal tedavi değil acil cerrahi yaklaşım seçilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 5: v163-new-005-ani-gelisen-norolojik-defisit

Başlık: Ani gelişen nörolojik defisit

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Nöroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Objektif verileri doğru yorumlayarak karar verdirici bulguyu seçme.

Learning Target: Akut iskemik inme şüphesinde tromboliz öncesi ilk görüntüleme basamağını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan konuşma bozukluğu ve sağ kol-bacak güçsüzlüğü nedeniyle acile getiriliyor. Yakınları semptomların 90 dakika önce normal konuşurken aniden başladığını belirtiyor. Bilinen atriyal fibrilasyon öyküsü vardır ancak düzenli antikoagülan kullanmadığı öğreniliyor. Kafa travması öyküsü yoktur.

Demografi: 71 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 165/95 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,65

Fizik Muayene

- Hasta uyanık ancak afaziktir.
- Sağ yüzde santral fasiyal paralizi, sağ üst ve alt ekstremitede belirgin motor güç kaybı mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetik 1: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hipoglisemi saptanmadı. | Klinik anlam: İnme taklitlerinden biri dışlanmıştır. | Sonuç yorumu: İnme taklitlerinden biri dışlanmıştır. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Hipoglisemi saptanmadı. | Yorum: İnme taklitlerinden biri dışlanmıştır. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / 112 mg/dL / 70-140 mg/dL / İnme taklitlerinden biri dışlanmıştır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada reperfüzyon tedavisi değerlendirilmeden önce yapılması gereken ilk görüntüleme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beyin manyetik rezonans difüzyon görüntüleme
B) Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi
C) Karotis Doppler ultrasonografi
D) Elektroensefalografi
E) Beyin pozitron emisyon tomografisi

Doğru Cevap: Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi

A) Beyin manyetik rezonans difüzyon görüntüleme: Beyin manyetik rezonans difüzyon görüntüleme erken iskemik için duyarlıdır ancak acil tromboliz öncesi ilk ve en hızlı standart görüntüleme değildir. Bu olguda “Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.” ve “Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi: Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi tromboliz öncesi intrakraniyal kanamayı hızlıca dışlamak için ilk tercih edilen görüntülemidir. Vakadaki “Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.” ve “Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Karotis Doppler ultrasonografi: Karotis Doppler ultrasonografi etiyolojik değerlendirmede yararlı olabilir fakat akut reperfüzyon kararından önce kanamayı dışlamaz. Bu olguda “Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.” ve “Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Elektroensefalografi: Elektroensefalografi nöbet veya nonkonvülfiz durum şüphesinde kullanılabilir ancak bu olguda ilk inme görüntülemesi değildir. Bu olguda “Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.” ve “Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Beyin pozitron emisyon tomografisi: Beyin pozitron emisyon tomografisi akut inme yönetiminde hızlı tromboliz kararını belirleyen ilk test değildir. Bu olguda “Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.” ve “Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani gelişen nörolojik defisit olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.” ve “Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.” birlikte okunduğunda Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneği öne çıkar; “Tedavi öncesi kanama dışlanmadan trombolitik karar güvenli değildir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Akut fokal nörolojik defisit ve kısa semptom süresi intravenöz tromboliz açısından değerlendirme gerektirir. Ancak reperfüzyon tedavisinden önce intrakraniyal kanama hızla dışlanmalıdır; bunun için ilk ve pratik görüntüleme kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.”, “Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.” ve “Tedavi öncesi kanama dışlanmadan trombolitik karar güvenli değildir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Konuşma bozukluğu ve tek taraflı güç kaybı akut fokal nörolojik defisit oluşturur.

Kanıt 2: Semptomların 90 dakika önce başlaması reperfüzyon penceresini gündeme getirir.

Kanıt 3: Tedavi öncesi kanama dışlanmadan trombolitik karar güvenli değildir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Akut inme şüphesinde trombolizden önce ilk hedef kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi ile kanamayı dışlamaktır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 6: v163-new-006-sag-alt-kadran-agrisi

Başlık: Sağ alt kadran ağrısı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Öykü, muayene ve objektif verilerden en olası tanıya ulaşma.

Learning Target: Akut apandisit tipik klinik ve laboratuvar bulgularla en olası tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, karın ağrısı ve bulantı nedeniyle acil servise başvuruyor. Ağrının yaklaşık 18 saat önce göbek çevresinde başladığını, daha sonra sağ alt kadrana yerleştiğini belirtiyor. İştahsızlık ve bir kez kusma tarifliyor. İshal veya idrar yaparken yanma tariflemiyor.

Demografi: 19 yaşında erkek hasta | Setting: Genel cerrahi acili

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/72 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.1°C | Şok indeksi: 0,86

Fizik Muayene

- Sağ alt kadranda belirgin hassasiyet, rebound ve istemli defans vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nötrofil ağırlıklı lökositoz saptandı. | Klinik anlam: Akut inflamatuvar süreçle uyumludur. | Sonuç yorumu: Akut inflamatuvar süreçle uyumludur. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Nötrofil ağırlıklı lökositoz saptandı. | Yorum: Akut inflamatuvar süreçle uyumludur. | Satırlar: Tam kan sayımı / 15.800 /mm³ / 4.500-11.000 /mm³ / Akut inflamatuvar süreçle uyumludur.

Tetkik 2: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: ultrasound | Alt tip: Ultrasonografi | Özet: Sağ alt kadranda komprese olmayan, çapı 8 mm ölçülen kör sonlanan tübüler yapı izlendi. | Klinik anlam: Lokalize cerrahi patoloji açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Lokalize cerrahi patoloji açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sağ alt kadranda komprese olmayan, çapı 8 mm ölçülen kör sonlanan tübüler yapı izlendi. | Yorum: Lokalize cerrahi patoloji açısından anlamlıdır. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Sağ alt kadranda komprese olmayan, çapı 8 mm ölçülen kör sonlanan tübüler yapı izlendi. // Lokalize cerrahi patoloji açısından anlamlıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-004 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sağ alt kadranda komprese olmayan, çapı 8 mm ölçülen kör sonlanan tübüler yapı izlendi. | Klinik anlam: Lokalize cerrahi patoloji açısından anlamlıdır. | URL: https://iukbtlkzxiqtqds.public.blob.vercel-storage.com/004_004-akut-apandisit-abdominal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqds.public.blob.vercel-storage.com/004_004-akut-apandisit-abdominal-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Sağ alt kadranda komprese olmayan, çapı 8 mm ölçülen kör sonlanan tübüler yapı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut gastroenterit
B) Meckel divertikülüti
C) Akut apandisit
D) Üreter taşı
E) Mezenter lenfadenit

Doğru Cevap: Akut apandisit

A) Akut gastroenterit: Akut gastroenteritte genellikle yaygın kramp tarzı ağrı ve ishal beklenir; lokal rebound-defans ve tipik ultrason bulgusu bu tanıyı geri plana iter. Bu olguda “Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Meckel divertikülüti: Meckel divertikülüti sağ alt kadran ağrısını taklit edebilir ancak verilen kör sonlanan komprese olmayan tübüler yapı bulgusu daha doğrudan apendiks kaynaklı süreci destekler. Bu olguda “Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Akut apandisit: Akut apandisit ağrı göçü, iştahsızlık, lokal periton irritasyonu, nötrofilik lökositoz ve ultrason bulgusuyla bu olguda en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereçlenir.

D) Üreter taşı: Üreter taşı kolik yan ağrısı ve hematüri ile beklenir; bu olguda üriner yakınma yoktur ve periton bulgusu ön plandadır. Bu olguda “Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Mezenter lenfadenit: Mezenter lenfadenit sağ alt kadran ağrısı yapabilir ancak belirgin rebound-defans ve apendiksi düşündüren ultrasonografik yapı varlığında en iyi açıklama değildir. Bu olguda “Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sağ alt kadran ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.” birlikte okunduğunda Akut apandisit seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide komprese olmayan genişlemiş kör sonlanan tübüler yapı izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Periumbilikal başlayan ağrının sağ alt kadrana göç etmesi, iştahsızlık, sağ alt kadranda rebound-defans, nötrofilik lökositoz ve komprese olmayan genişlemiş kör sonlanan tübüler yapı akut apandisit için tipiktir. Diğer seçenekler bazı bulguları taklit edebilir ancak ağrı migrasyonu ve ultrasonografik görünüm birlikte değerlendirildiğinde en olası tanı budur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.”, “Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.” ve “Ultrasonografide komprese olmayan genişlemiş kör sonlanan tübüler yapı izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut apandisit en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ağrı periumbilikal bölgeden sağ alt kadrana göç etmiştir.

Kanıt 2: Sağ alt kadranda rebound ve defans lokal periton irritasyonunu gösterir.

Kanıt 3: Ultrasonografide komprese olmayan genişlemiş kör sonlanan tübüler yapı izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Periumbilikal ağrının sağ alt kadrana göçü ve lokal periton bulgusu akut apandisit için klasik sınav ipucudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 7: v163-new-007-kolinergik-bulgularla-zehirlenme

Başlık: Kolinergik bulgularla zehirlenme

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Organofosfat zehirlenmesinde antidot mekanizmasını ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, nefes darlığı, terleme ve bilinç bulanıklığı nedeniyle acile getiriliyor. Yakınları hastanın kapalı alanda insektisit uyguladıktan sonra bulantı, karın krampları, tükürük artışı ve görme bulanıklığı yaşadığını söylüyor. Bilinen nörolojik hastalık öyküsü yoktur.

Demografi: 42 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 95/60 mmHg | Nabız: 52/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %88% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,55

Fizik Muayene

- Hasta konfüzedir.
- Belirgin miyozis, aşırı salivasyon, bronkore, yaygın terleme ve fasikülasyonlar izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma kolinesteraz aktivitesi

Etiket: Plazma kolinesteraz aktivitesi | Tip: toxicology | Alt tip: Toksikoloji | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Maruziyetin biyokimyasal etkisini destekler. | Sonuç yorumu: Maruziyetin biyokimyasal etkisini destekler. | Sonuç başlığı: Plazma kolinesteraz aktivitesi | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Maruziyetin biyokimyasal etkisini destekler. | Satırlar: Plazma kolinesteraz aktivitesi / Belirgin düşük saptandı. // Maruziyetin biyokimyasal etkisini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada pralidoksimin temel tedavi edici mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Muskarinik asetilkolin reseptörlerini kompetitif olarak bloke etmesi
B) Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi
C) Gama-aminobütirik asit reseptörlerini potansiyalize etmesi
D) Nikotinik asetilkolin reseptörlerini geri dönüşümsüz inhibe etmesi
E) Katekolamin geri alımını inhibe etmesi

Doğru Cevap: Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi

A) Muskarinik asetilkolin reseptörlerini kompetitif olarak bloke etmesi: Muskarinik asetilkolin reseptörlerinin kompetitif blokajı atropinin etkisidir; pralidoksimin temel mekanizması reseptör blokajı değildir. Bu olguda “Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.” ve “Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi: Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi pralidoksimin organofosfat zehirlenmesindeki ayırt edici mekanizmasıdır. Vakadaki “Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.” ve “Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereksizdir.

C) Gama-aminobütirik asit reseptörlerini potansiyalize etmesi: Gama-aminobütirik asit reseptörlerinin potansiyalizasyonu benzodiazepinlerin nöbet kontrolündeki etkisidir ve bu antidotun temel mekanizması değildir. Bu olguda “Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.” ve “Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nikotinik asetilkolin reseptörlerini geri dönüşümsüz inhibe etmesi: Nikotinik asetilkolin reseptörlerinin geri dönüşümsüz inhibisyonu pralidoksimin etkisi değildir; enzim aktivitesini geri kazandırarak asetilkolin birikimini azaltır. Bu olguda “Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.” ve “Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Katekolamin geri alımını inhibe etmesi: Katekolamin geri alımının inhibisyonu sempatomimetik etkiyle ilişkilidir ve bu kolinerjik toksidromun antidot mekanizmasını açıklamaz. Bu olguda “Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.” ve “Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kolinergik bulgularla zehirlenme olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.” ve “Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.” birlikte okunduğunda Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi seçeneği öne çıkar; “Fasikülasyonlar nöromüsküler kavşakta nikotinik etkilenmeyi düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu olguda miyozis, bronkore, salivasyon, bradikardi, fasikülasyon ve düşük kolinesteraz aktivitesi organofosfat maruziyetini düşündürür. Pralidoksim, fosforillenmiş asetilkolinesterazı yaşlanma gelişmeden önce yeniden aktive ederek özellikle nikotinik bulguların düzelmesine katkı sağlar; muskarinik bulgular için atropin kullanılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.”, “Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.” ve “Fasikülasyonlar nöromüsküler kavşakta nikotinik etkilenmeyi düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Asetilkolinesteraz enzimini yeniden aktive etmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kapalı alanda insektisit maruziyeti öyküsü vardır.

Kanıt 2: Miyozis, bronkore, salivasyon ve bradikardi kolinerjik aşırı aktiviteyi gösterir.

Kanıt 3: Fasikülasyonlar nöromüsküler kavşakta nikotinik etkilenmeyi düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Organofosfat zehirlenmesinde atropin muskarinik reseptörleri bloke eder; pralidoksim asetilkolinesterazı yeniden aktive eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 8: v163-new-008-kronik-malabsorpsiyon-tablosu

Başlık: Kronik malabsorpsiyon tablosu

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Patoloji / Gastroenteroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloyu morfolojik veya histopatolojik paternle ilişkilendirme.

Learning Target: Çölyak hastalığında tipik histopatolojik bulguyu seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kronik ishal, kilo kaybı ve halsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Son bir yıldır özellikle ekmek ve makarna içeren öğünlerden sonra karında şişkinlik ve kötü kokulu dışkılama olduğunu belirtiyor. Demir eksikliği nedeniyle birkaç kez tedavi aldığı ancak yakınmalarının tekrarladığı öğreniliyor.

Demografi: 31 yaşında kadın hasta | Setting: Gastroenteroloji polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta zayıf görünümündedir.
- Konjonktival solukluk mevcuttur.
- Batında yaygın hafif distansiyon vardır; belirgin defans veya organomegali saptanmamıştır.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Anti-doku transglutaminaz IgA

Etiket: Anti-doku transglutaminaz IgA | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Otoimmün enteropati olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Otoimmün enteropati olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Anti-doku transglutaminaz IgA | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Otoimmün enteropati olasılığını destekler. | Satırlar: Anti-doku transglutaminaz IgA / Pozitif saptandı. // Otoimmün enteropati olasılığını destekler.

Tetkik 2: Duodenum biyopsisi

Etiket: Duodenum biyopsisi | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Histolojik değerlendirme planlandı. | Klinik anlam: Mukozal hasarın gösterilmesi için gereklidir. | Sonuç yorumu: Mukozal hasarın gösterilmesi için gereklidir. | Sonuç başlığı: Duodenum biyopsisi | Sonuç özeti: Histolojik değerlendirme planlandı. | Yorum: Mukozal hasarın gösterilmesi için gereklidir. | Satırlar: Duodenum biyopsisi / Histolojik değerlendirme planlandı. // Mukozal hasarın gösterilmesi için gereklidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-005 | Başlık: Duodenum biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Histolojik değerlendirme planlandı. | Klinik anlam: Mukozal hasarın gösterilmesi için gereklidir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/005_005-villus-atrofisi-duodenum-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/005_005-villus-atrofisi-duodenum-histopatoloji.webp | Alt text: Duodenum biyopsisi - Histolojik değerlendirme planlandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastanın duodenum biyopsisinde beklenen temel histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kript apseleri ve devamlı mukozal ülserasyon
B) Transmural granülatöz inflamasyon
C) Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı
D) Submukozal vasküler ektazi ve hemosiderin birikimi
E) Pilonik gland metaplazisi ve Helicobacter benzeri organizmalar

Doğru Cevap: Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı

- A) Kript apseleri ve devamlı mukozal ülserasyon: Kript apseleri ve devamlı mukozal ülserasyon ülseratif koliti düşündürür; bu olguda ince bağırsak malabsorpsiyonu ve gluten ilişkisi ön plandadır. Bu olguda “Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.” ve “Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Transmural granülatöz inflamasyon: Transmural granülatöz inflamasyon Crohn hastalığı için daha tipiktir ve verilen serolojik-malabsorptif tabloyu en iyi açıklamaz. Bu olguda “Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.” ve “Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı: Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı gluten duyarlı enteropatide beklenen temel histopatolojik paternlerdir. Vakadaki “Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.” ve “Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- D) Submukozal vasküler ektazi ve hemosiderin birikimi: Submukozal vasküler ektazi ve hemosiderin birikimi kronik kanama odaklarını düşündürür ancak bu Vakadaki immün malabsorpsiyon bulgularını açıklamaz. Bu olguda “Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.” ve “Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Pilonik gland metaplazisi ve Helicobacter benzeri organizmalar: Pilonik gland metaplazisi ve Helicobacter benzeri organizmalar gastrik patolojiyle ilişkilidir; duodenal malabsorpsiyon tablosunun temel biyopsi bulgusu değildir. Bu olguda “Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.” ve “Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik malabsorpsiyon tablosu olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.” ve “Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.” birlikte okunduğunda Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı seçeneği öne çıkar; “Anti-doku transglutaminaz IgA pozitifliği immün aracıli ince bağırsak hasarını destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik ishal, malabsorpsiyon, demir eksikliği, glutenle ilişkili yakınmalar ve anti-doku transglutaminaz IgA pozitifliği çölyak hastalığını destekler. Bu tabloda duodenum biyopsisinde villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı beklenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.”, “Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.” ve “Anti-doku transglutaminaz IgA pozitifliği immün aracıli ince bağırsak hasarını destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışı en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Kötü kokulu dışkılama ve kilo kaybı malabsorpsiyonu düşündürür.

Kanıt 2: Buğday içeren gıdalar sonrası karın şişkinliği yakınmaları artmaktadır.

Kanıt 3: Anti-doku transglutaminaz IgA pozitifliği immün aracıli ince bağırsak hasarını destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Çölyak hastalığında klasik biyopsi triadı villus atrofiksi, kript hiperplazisi ve intraepitelyal lenfosit artışıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 9: v163-new-009-omuz-travmasi-sonrasi-guc-kaybi

Başlık: Omuz travması sonrası güç kaybı

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi / Ortopedi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Muayene bulgusunu anatomik yapı ve sinir-yapı ilişkisiyle eşleştirme.

Learning Target: Cerrahi boyun humerus kırığında hasarlanma riski olan siniri klinik bulguyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ omuz ağrısı ve kolunu yana kaldıramama şikâyetiyle başvuruyor. Merdivenden düşerken sağ omzu üzerine çarptığını, travmadan sonra kolunu özellikle gövdeden uzaklaştırmakta zorlandığını belirtiyor. Daha önce aynı omuzdan cerrahi geçirmemiştir.

Demografi: 56 yaşında kadın hasta | Setting: Ortopedi acili

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ omuzda şişlik, hassasiyet ve hareket kısıtlılığı vardır.
- Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük izlenir.
- Deltoid bölge üzerindeki cilt duyusu azalmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Sağ omuz direkt grafisi

Etiket: Sağ omuz direkt grafisi | Tip: xray | Alt tip: Direkt grafi | Özet: Humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlendi. | Klinik anlam: Komşu nörovasküler yapıların değerlendirilmesini gerektirir. | Sonuç yorumu: Komşu nörovasküler yapıların değerlendirilmesini gerektirir. | Sonuç başlığı: Sağ omuz direkt grafisi | Sonuç özeti: Humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlendi. | Yorum: Komşu nörovasküler yapıların değerlendirilmesini gerektirir. | Satırlar: Sağ omuz direkt grafisi / Humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlendi. / Komşu nörovasküler yapıların değerlendirilmesini gerektirir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-006 | Başlık: Sağ omuz direkt grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlendi. | Klinik anlam: Komşu nörovasküler yapıların değerlendirilmesini gerektirir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/006_006-humerus-cerrahi-boyun-kirigi-direkt-grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/006_006-humerus-cerrahi-boyun-kirigi-direkt-grafi.webp | Alt text: Sağ omuz direkt grafisi - Humerus cerrahi boyun bölgesinde kırık hattı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma riski en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus musculocutaneus
B) Nervus medianus
C) Nervus radialis
D) Nervus axillaris
E) Nervus ulnaris

Doğru Cevap: Nervus axillaris

A) Nervus musculocutaneus: Nervus musculocutaneus ön kol fleksörlerini ve lateral ön kol duyusunu etkiler; deltoid bölge duyusu ve omuz abduksiyonu ile birincil ilişkili değildir. Bu olguda “Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.” ve “Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nervus medianus: Nervus medianus el bileği ve parmak fleksiyonu ile tenar fonksiyonlar açısından önemlidir; humerus cerrahi boyun kırığındaki deltoid bulgularını açıklamaz. Bu olguda “Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.” ve “Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus radialis: Nervus radialis humerus shaft kırıklarında spiral oluk düzeyinde risk altındadır ve el bileği ekstansiyon kaybı beklenir. Bu olguda “Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.” ve “Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nervus axillaris: Nervus axillaris humerus cerrahi boyun çevresinden geçtiği, deltoid kasi innerve ettiği ve lateral omuz duyusunu taşıdığı için bu olguda en riskli sinirdir. Vakadaki “Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.” ve “Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

E) Nervus ulnaris: Nervus ulnaris medial epikondil ve Guyon kanalı düzeyindeki lezyonlarla ilişkilidir; omuz abduksiyonu ve deltoid duyu kaybını açıklamaz. Bu olguda “Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.” ve “Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Omuz travması sonrası güç kaybı olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.” ve “Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.” birlikte okunduğunda Nervus axillaris seçeneği öne çıkar; “Deltoid bölge üzerinde cilt duyusu azalmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Humerusun cerrahi boyun kırıkları nervus axillaris hasarı açısından risklidir. Bu sinir deltoid kasi innerve eder ve omuz lateralinde duyu taşır; bu nedenle abduksiyon güçsüzlüğü ve deltoid bölge duyu azalması aynı anatomik hasarı destekler. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.”, “Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.” ve “Deltoid bölge üzerinde cilt duyusu azalmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus axillaris en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Direkt grafide humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.

Kanıt 2: Omuz abduksiyonunda belirgin güçsüzlük vardır.

Kanıt 3: Deltoid bölge üzerinde cilt duyusu azalmıştır.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguya uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Humerus cerrahi boyun kırığı, deltoid güçsüzlüğü ve lateral omuz duyu kaybı nervus axillaris hasarını düşündürür.

Kaliite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 10: v163-new-010-aclıkla-belirginlesen-metabolik-tablo

Başlık: Açlıkla belirginleşen metabolik tablo

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Biyokimya / Metabolizma | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Von Gierke hastalığında hipoglisemi mekanizmasını ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme aralarında terleme, huzursuzluk ve nöbet benzeri ataklar nedeniyle getiriliyor. Aile, bebeğin özellikle gece beslenmesi geciktiğinde belirgin halsizleştiğini ve beslenmeden sonra kısmen düzeldiğini belirtiyor. Doğum öyküsünde belirgin sorun yoktur.

Demografi: 8 aylık kız bebek | Setting: Çocuk metabolizma polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebek iritabl görünümündedir.
- Batın muayenesinde karaciğer belirgin palpe edilmektedir.
- Büyüme eğrisinde kilo alımı yetersizdir.
- Vital bulgular stabil sınırlardadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Açlık kan glukozu

Etiket: Açlık kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Açlık intoleransını gösterir. | Sonuç yorumu: Açlık intoleransını gösterir. | Sonuç başlığı: Açlık kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Açlık intoleransını gösterir. | Satırlar: Açlık kan glukozu / 38 mg/dL / 70-100 mg/dL / Açlık intoleransını gösterir.

Tetkik 2: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Glukoz üretim basamağındaki blokla ilişkilidir. | Sonuç yorumu: Glukoz üretim basamağındaki blokla ilişkilidir. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Glukoz üretim basamağındaki blokla ilişkilidir. | Satırlar: Serum laktat / 6.2 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L / Glukoz üretim basamağındaki blokla ilişkilidir.

Tetkik 3: Serum ürik asit

Etiket: Serum ürik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Metabolik yan ürün artışı destekler. | Sonuç yorumu: Metabolik yan ürün artışı destekler. | Sonuç başlığı: Serum ürik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Metabolik yan ürün artışı destekler. | Satırlar: Serum ürik asit / 8.9 mg/dL / 2.0-5.5 mg/dL / Metabolik yan ürün artışı destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki açlık hipoglisemisinin temel mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Glukojen fosforilaz aktivitesinin kas dokusunda azalması
- B) Lizozomal alfa-1, 4-glukozidaz aktivitesinin azalması
- C) Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması
- D) Dallanma enzimi aktivitesinin azalması
- E) Fruktoz-1-fosfat aldolaz aktivitesinin azalması

Doğru Cevap: Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması

A) Glukojen fosforilaz aktivitesinin kas dokusunda azalması: Kas glukojen fosforilaz eksikliği egzersiz intoleransı ve kas kramplarıyla seyreder; karaciğer kaynaklı açlık hipoglisemisini açıklamaz. Bu olguda “Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.” ve “Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Lizozomal alfa-1, 4-glukozidaz aktivitesinin azalması: Lizozomal alfa-1, 4-glukozidaz eksikliği kardiyomiyopati ve hipotoniyle öne çıkar; laktik asidozlu ağır açlık hipoglisemisi için en uygun mekanizma değildir. Bu olguda “Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.” ve “Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması: Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması karaciğerde serbest glukoz üretimini engelleyerek açlık hipoglisemisi, laktik asidoz ve hepatomegaliye yol açar. Vakadaki “Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.” ve “Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Dallanma enzimi aktivitesinin azalması: Dallanma enzimi eksikliği anormal glukojen birikimi ve karaciğer hastalığı yapabilir ancak bu olgunun tipik laktat-ürik asit paterniyle en iyi açıklama değildir. Bu olguda “Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.” ve “Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Fruktoz-1-fosfat aldolaz aktivitesinin azalması: Fruktoz-1-fosfat aldolaz eksikliği fruktoz alımı sonrası semptom verir; burada temel tetikleyici açlık ve beslenme gecikmesidir. Bu olguda “Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.” ve “Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlıkla belirginleşen metabolik tablo olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.” ve “Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.” birlikte okunduğunda Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması seçeneği öne çıkar; “Laktat ve ürik asit yüksekliği metabolik blok sonrası ara ürünlerin alternatif yollara kaydığını düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Açlıkla ağır hipoglisemi, hepatomegali, laktik asidoz ve hiperürisemi glukoz-6-fosfataz eksikliğini düşündürür. Bu enzim hem glukojenoliz hem de glukoneogenez sonucu oluşan glukoz-6-fosfatın serbest glukozla dönüştürülmesi için gereklidir; eksikliğinde karaciğer kana glukoz veremez. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.”, “Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.” ve “Laktat ve ürik asit yüksekliği metabolik blok sonrası ara ürünlerin alternatif yollara kaydığını düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Glukoz-6-fosfataz aktivitesinin azalması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Beslenme geciktiğinde hipoglisemik atakların belirginleşmesi açlık intoleransını gösterir.

Kanıt 2: Hepatomegali karaciğerde glukojen birikimini destekler.

Kanıt 3: Laktat ve ürik asit yüksekliği metabolik blok sonrası ara ürünlerin alternatif yollara kaydığını düşündürür.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olabilir.

Exam Pearl: Glukoz-6-fosfataz eksikliğinde hem glukojenoliz hem glukoneogenez son basamakta serbest glukoz üretemez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 11: v164-new-011-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma

Başlık: Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Endokrinoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Diyabetik ketoasidozda ilk tedavi basamağını hemodinamik durumla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kusma, karın ağrısı ve derin solunum nedeniyle acil servise getiriliyor. Son iki gündür insülin dozlarını aksattığı, giderek artan susama ve sık idrara çıkma yakınması olduğu öğreniliyor. Son 12 saatte tekrarlayan kusmaları olmuş ve oral alımı belirgin azalmıştır.

Demografi: 17 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 90/55 mmHg | Nabız: 126/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,40 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta dehidrate ve halsiz görünümündedir.
- Mukozalar kurudur, solunumu derin ve hızlıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma glukozu

Etiket: Plazma glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hiperglisemik acil tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Hiperglisemik acil tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma glukozu | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hiperglisemik acil tabloyu destekler. | Satırlar: Plazma glukozu / 548 mg/dL / 70-140 mg/dL / Hiperglisemik acil tabloyu destekler.

Tetkik 2: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz ile uyumlu sonuç izlendi. | Klinik anlam: Asit-baz bozukluğunun ciddiyetini gösterir. | Sonuç yorumu: Asit-baz bozukluğunun ciddiyetini gösterir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz ile uyumlu sonuç izlendi. | Yorum: Asit-baz bozukluğunun ciddiyetini gösterir. | Satırlar: Arter kan gazı (pH) / 7.12 / 7.35-7.45 / Asit-baz bozukluğunun ciddiyetini gösterir.

Tetkik 3: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal-yüksek aralıkta ölçüldü. | Klinik anlam: Tedavi sırasında yakın izlem gerektirir. | Sonuç yorumu: Tedavi sırasında yakın izlem gerektirir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Normal-yüksek aralıkta ölçüldü. | Yorum: Tedavi sırasında yakın izlem gerektirir. | Satırlar: Serum potasyum / 5.3 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Tedavi sırasında yakın izlem gerektirir.

Tetkik 4: İdrar ketonu

Etiket: İdrar ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Ketotik metabolik süreci destekler. | Sonuç yorumu: Ketotik metabolik süreci destekler. | Sonuç başlığı: İdrar ketonu | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Ketotik metabolik süreci destekler. | Satırlar: İdrar ketonu / Pozitif saptandı. // Ketotik metabolik süreci destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-250 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Mukozalar kurudur, solunumu derin ve hızlıdır. | Klinik anlam: İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması | URL: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/250_anxious_patient_in_hospital_bed.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/250_anxious_patient_in_hospital_bed.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Mukozalar kurudur, solunumu derin ve hızlıdır. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk uygulanması gereken tedavi basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz düzenli insülin infüzyonu başlanması
B) İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi
C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanması
D) İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması
E) Potasyum replasmanına hemen başlanması

Doğru Cevap: İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması

- A) İntravenöz düzenli insülin infüzyonu başlanması: İntravenöz düzenli insülin temel tedavidir ancak belirgin dehidratasyon ve hipotansiyon varken ilk olarak sıvı resüsitasyonu yapılmalıdır. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.” ve “Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi: Sodyum bikarbonat yalnızca çok ağır asidoz gibi seçilmiş durumlarda düşünülür; bu olguda ilk basamak sıvı replasmanıdır. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.” ve “Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanması: Subkutan hızlı etkili insülin ağır asidoz ve dolaşım bozukluğu olan hastada uygun ilk yaklaşım değildir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.” ve “Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması: İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu hipovolemiyi ve doku perfüzyonunu düzelttiği için bu hastada ilk tedavi basamağıdır. Vakadaki “İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.” ve “Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- E) Potasyum replasmanına hemen başlanması: Potasyum replasmanı tedavi sırasında gerekebilir ancak başlangıç potasyumu yüksekken hemen replasman yapmak uygun değildir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.” ve “Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.” ve “Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.” birlikte okunduğunda İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması seçeneği öne çıkar; “Kuru mukozalar, taşikardi ve hipotansiyon belirgin hacim kaybını gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada hiperglisemi, keton pozitifliği, metabolik asidoz, dehidratasyon, taşikardi ve hipotansiyon diyabetik ketoasidoz tablosunu düşündürür. İlk tedavi basamağı dolaşım hacmini düzeltmek için izotonik salinle sıvı resüsitasyonudur; insülin tedavisi sıvı başlanıp potasyum durumu güvenli şekilde değerlendirildikten sonra uygulanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.”, “Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.” ve “Kuru mukozalar, taşikardi ve hipotansiyon belirgin hacim kaybını gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İzotonik salin ile sıvı resüsitasyonu yapılması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: İnsülin dozlarının aksaması sonrası poliüri, susama, kusma ve derin solunum gelişmiştir.

Kanıt 2: Plazma glukozu yüksek, pH düşük ve idrar ketonu pozitifdir.

Kanıt 3: Kuru mukozalar, taşikardi ve hipotansiyon belirgin hacim kaybını gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Diyabetik ketoasidozda ilk adım çoğu hastada insülin değil, dolaşım hacmini düzelter izotonik sıvı tedavisidir.

BRANŞ: pediatrics

VAKA 12: v164-new-012-beslenme-sonrasi-kusan-bebek

Başlık: Beslenme sonrası kusan bebek

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Çocuk Cerrahisi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Hipertrofik pilor stenozunda kesin tedaviyi stabilizasyon koşuluyla seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme sonrası tekrarlayan fışkırır tarzda kusma nedeniyle getiriliyor. Kusmaların son 10 gündür giderek arttığı, kusmanın safra içermediği ve bebeğin kusmadan sonra tekrar acıktığı öğreniliyor. Aile son günlerde idrar miktarında azalma ve kilo alımında yavaşlama fark ettiğini belirtiyor.

Demografi: 5 haftalık erkek bebek | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/54 mmHg | Nabız: 154/dk | Solunum: 32/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,79 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek huzursuz ve hafif dehidrate görünümündedir.
- Üst batında beslenme sonrası peristaltik dalgalar izlenir ve epigastrik bölgede küçük, sert, hareketli kitle palpe edilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetik 1: Serum klor

Etiket: Serum klor | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kusmaya bağlı elektrolit kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Kusmaya bağlı elektrolit kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Serum klor | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kusmaya bağlı elektrolit kaybını destekler. | Satırlar: Serum klor / 88 mmol/L / 98-106 mmol/L / Kusmaya bağlı elektrolit kaybını destekler.

Tetik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Tedavi öncesi düzeltilmesi gereken elektrolit bozukluğudur. | Sonuç yorumu: Tedavi öncesi düzeltilmesi gereken elektrolit bozukluğudur. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Tedavi öncesi düzeltilmesi gereken elektrolit bozukluğudur. | Satırlar: Serum potasyum / 3.0 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Tedavi öncesi düzeltilmesi gereken elektrolit bozukluğudur.

Tetik 3: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: ultrasound | Alt tip: Ultrasonografi | Özet: Pilor kasında belirgin kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlendi. | Klinik anlam: Mekanik gastrik çıkış darlığını destekler. | Sonuç yorumu: Mekanik gastrik çıkış darlığını destekler. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Pilor kasında belirgin kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlendi. | Yorum: Mekanik gastrik çıkış darlığını destekler. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Pilor kasında belirgin kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlendi. / / Mekanik gastrik çıkış darlığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-007 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Pilor kasında belirgin kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlendi. | Klinik anlam: Mekanik gastrik çıkış darlığını destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/007_007-hipertrofik-pilor-stenozu-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/007_007-hipertrofik-pilor-stenozu-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Pilor kasında belirgin kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Sıvı ve elektrolit bozuklukları düzeltildikten sonra bu hastada en uygun kesin tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ramstedt piloromiyotomi
B) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi
C) Proton pompa inhibitörü tedavisi
D) Acil total parenteral beslenme
E) Laktozsuz mama ile beslenme düzenlenmesi

Doğru Cevap: Ramstedt piloromiyotomi

- A) Ramstedt piloromiyotomi: Ramstedt piloromiyotomi sıvı-elektrolit stabilizasyonundan sonra gastrik çıkış obstrüksiyonunu kalıcı olarak düzelteren kesin tedavidir. Vakadaki “Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.” ve “Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereksizdir.
- B) Geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi: Geniş spektrumlu antibiyotik enfeksiyon bulgusu olmayan bu mekanik obstrüksiyon tablosunun kesin tedavisi değildir. Bu olguda “Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.” ve “Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ramstedt piloromiyotomi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Proton pompa inhibitörü tedavisi: Proton pompa inhibitörü reflü veya asit ilişkili yakınmalarda kullanılabilir ancak pilor kas hipertrofisine bağlı obstrüksiyonu çözmez. Bu olguda “Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.” ve “Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ramstedt piloromiyotomi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Acil total parenteral beslenme: Total parenteral beslenme geçici destek olabilir fakat anatomik darlığı ortadan kaldırmadığı için kesin tedavi değildir. Bu olguda “Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.” ve “Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ramstedt piloromiyotomi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Laktozsuz mama ile beslenme düzenlenmesi: Laktozsuz mama besin intoleransında düşünülebilir ancak fışkırır safrsız kusma ve ultrason bulgularıyla açıklanan mekanik darlığı tedavi etmez. Bu olguda “Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.” ve “Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ramstedt piloromiyotomi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Beslenme sonrası kusan bebek olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.” ve “Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.” birlikte okunduğunda Ramstedt piloromiyotomi seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide pilor kasında kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Safrsız fışkırır kusma, kusma sonrası açlık, üst batında peristaltik dalga, palpe edilen kitle, hipokloremik hipokalemik tablo ve ultrasonografide pilor kas kalınlaşması hipertrofik pilor stenozunu destekler. Bu hastada önce sıvı-elektrolit bozuklukları düzeltilir, ardından kesin tedavi Ramstedt piloromiyotomisidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.”, “Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.” ve “Ultrasonografide pilor kasında kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ramstedt piloromiyotomi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Beslenme sonrası safrsız fışkırır tarzda kusma tariflenmiştir.

Kanıt 2: Epigastrik bölgede küçük sert kitle ve üst batında peristaltik dalgalar vardır.

Kanıt 3: Ultrasonografide pilor kasında kalınlaşma ve kanal uzunluğunda artış izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Hipertrofik pilor stenozunda cerrahi kesin tedavidir ancak önce dehidratasyon ve elektrolit bozukluğu düzeltilmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 13: v164-new-013-atesli-monoartrit

Başlık: Ateşli monoartrit

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Ortopedi / Enfeksiyon Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Objektif verileri doğru yorumlayarak karar verdirici bulguyu seçme.

Learning Target: Akut septik artrit şüphesinde ilk tanısal işlemi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ dizde ani gelişen ağrı, şişlik ve ateş nedeniyle başvuruyor. Şikâyetlerin bir gün içinde hızla arttığı, diz üzerine basmakta zorlandığı öğreniliyor. Tip 2 diyabet öyküsü vardır. Daha önce gut tanısı almamıştır ve yakın zamanda travma tariflememektedir.

Demografi: 63 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 130/78 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.7°C | Şok indeksi: 0,86

Fizik Muayene

- Sağ diz belirgin şiş, sıcak ve hareketle ileri derecede ağrılıdır.
- Eklem hareket açıklığı ciddi kısıtlıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut inflamatuvar süreci destekler. | Sonuç yorumu: Akut inflamatuvar süreci destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut inflamatuvar süreci destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 146 mg/L / <5 mg/L / Akut inflamatuvar süreci destekler.

Tetkik 2: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nötrofil ağırlıklı lökositoz saptandı. | Klinik anlam: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını artırır. | Sonuç yorumu: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını artırır. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Nötrofil ağırlıklı lökositoz saptandı. | Yorum: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını artırır. | Satırlar: Tam kan sayımı / 18.200 /mm³ / 4.500-11.000 /mm³ / Bakteriyel enfeksiyon olasılığını artırır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada tanıyı kesinleştirmek ve tedaviyi yönlendirmek için yapılması gereken ilk tanısal işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Diz manyetik rezonans görüntüleme
B) Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi
C) Serum ürik asit düzeyi ölçümü
D) Diz direkt grafisi
E) Antinükleer antikor testi

Doğru Cevap: Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi

A) Diz manyetik rezonans görüntüleme: Manyetik rezonans görüntüleme derin yumuşak doku veya osteomyelit şüphesinde yararlı olabilir ancak akut septik artritte ilk tanısal işlem değildir. Bu olguda "Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır." ve "Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi: Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi mikrobiyolojik tanıyı, kristal ayrımını ve hedefe yönelik tedaviyi sağladığı için ilk tanısal işlemdir. Vakadaki "Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır." ve "Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Serum ürik asit düzeyi ölçümü: Vakadaki Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır ve Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler. Bu olguda "Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır." ve "Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Diz direkt grafisi: Direkt grafi kemik patolojisini gösterebilir ancak erken septik artritte tanıyı kesinleştirme ve etkeni belirleme gücü sınırlıdır. Bu olguda "Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır." ve "Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Antinükleer antikor testi: Antinükleer antikor testi otoimmün hastalık taraması için kullanılabilir; ateşli akut monoartritte acil tanısal öncelik değildir. Bu olguda "Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır." ve "Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateşli monoartrit olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır." ve "Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler." birlikte okunduğunda Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi seçeneği öne çıkar; "Eklem hareketi ileri derecede ağrılı ve kısıtlıdır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, akut tek eklem şişliği, sıcaklık artışı, hareketle şiddetli ağrı ve inflamatuvar belirteç yüksekliği septik artrit açısından acil değerlendirme gerektirir. Tanıyı kesinleştiren ve etken ile antibiyotik seçimini yönlendiren temel işlem eklem aspirasyonu ile sinovyal sıvının hücre sayımı, Gram boyama, kültür ve kristal açısından incelenmesidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır.", "Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler." ve "Eklem hareketi ileri derecede ağrılı ve kısıtlıdır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Eklem aspirasyonu ve sinovyal sıvı analizi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Tek dizde ani başlayan ağrı, şişlik ve ısı artışı vardır.

Kanıt 2: Ateş, lökositoz ve C-reaktif protein yüksekliği enfeksiyöz süreci destekler.

Kanıt 3: Eklem hareketi ileri derecede ağrılı ve kısıtlıdır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 14: v164-new-014-purpura-ve-norolojik-bulgular

Başlık: Purpura ve nörolojik bulgular

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Hematoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Trombotik mikroanjyopati tablosunda acil tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yaygın morluklar, baş ağrısı ve dalgalanan bilinç bulanıklığı nedeniyle acile getiriliyor. Son üç gündür halsizlik, burun kanaması ve ateş hissi olduğu öğreniliyor. Bilinen otoimmün hastalığı yoktur. Yakın zamanda ishal öyküsü tariflememektedir.

Demografi: 34 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 138/84 mmHg | Nabız: 106/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.2°C | Şok indeksi: 0,77

Fizik Muayene

- Hasta intermittan konfüzidir.
- Ekstremitelerde peteşi ve ekimozlar izlenir.
- Belirgin meningeal irritasyon bulgusu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir. | Sonuç yorumu: Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 18.000 /mm³ / 150.000-400.000 /mm³ / Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir.

Tetkik 2: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: microscopy | Alt tip: Mikroskopi | Özet: Şistositler görüldü. | Klinik anlam: Mekanik eritrosit parçalanmasını gösterir. | Sonuç yorumu: Mekanik eritrosit parçalanmasını gösterir. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Şistositler görüldü. | Yorum: Mekanik eritrosit parçalanmasını gösterir. | Satırlar: Periferik yayma / Şistositler görüldü. / / Mekanik eritrosit parçalanmasını gösterir.

Tetkik 3: Laktat dehidrogenaz

Etiket: Laktat dehidrogenaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hemoliz ve doku hasarıyla ilişkili olabilir. | Sonuç yorumu: Hemoliz ve doku hasarıyla ilişkili olabilir. | Sonuç başlığı: Laktat dehidrogenaz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hemoliz ve doku hasarıyla ilişkili olabilir. | Satırlar: Laktat dehidrogenaz / 1240 U/L / 135-225 U/L / Hemoliz ve doku hasarıyla ilişkili olabilir.

Tetkik 4: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hafif yüksek saptandı. | Klinik anlam: Organ etkilenimini destekler. | Sonuç yorumu: Organ etkilenimini destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Hafif yüksek saptandı. | Yorum: Organ etkilenimini destekler. | Satırlar: Serum kreatinin / 1.6 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Organ etkilenimini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-008 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Şistositler görüldü. | Klinik anlam: Mekanik eritrosit parçalanmasını gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/008_008-sistositler-periferik-yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/008_008-sistositler-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Şistositler görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready
Görsel 2: ID: visual-251 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Ekstremitelerde peteşi ve ekimozlar izlenir. | Klinik anlam: Plazma değişimi | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/251_severe_bruising_and_purpura_on_legs.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/251_severe_bruising_and_purpura_on_legs.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Ekstremitelerde peteşi ve ekimozlar izlenir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada acilen başlanması gereken en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trombosit transfüzyonu
B) Düşük molekül ağırlıklı heparin
C) Oral demir tedavisi
D) Yüksek doz intravenöz immünglobulin
E) Plazma değişimi

Doğru Cevap: Plazma değişimi

A) Trombosit transfüzyonu: Trombosit transfüzyonu hayatı tehdit eden kanama yoksa mikrotrombozu arttırılabileceği için bu tabloda rutin ilk tedavi değildir. Bu olguda “Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.” ve “Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.
B) Düşük molekül ağırlıklı heparin: Düşük molekül ağırlıklı heparin venöz tromboemboli tedavisinde kullanılır; mikroanjyopatik hemoliz ve ağır trombositopeni tablosunu düzeltmez. Bu olguda “Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.” ve “Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Oral demir tedavisi: Oral demir tedavisi demir eksikliği anemisinde etkilidir ancak şistositli akut hemolitik süreci ve organ etkilenimini tedavi etmez. Bu olguda “Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.” ve “Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Yüksek doz intravenöz immünglobulin: Intravenöz immünglobulin immün trombositopenide kullanılabilir; bu olguda mikroanjyopatik hemoliz ve nörolojik bulgular farklı bir acil tedaviyi gerektirir. Bu olguda “Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.” ve “Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Plazma değişimi: Plazma değişimi patolojik dolaşımdaki faktörleri uzaklaştırıp eksik proteaz aktivitesini yerine koyduğu için bu akut trombotik mikroanjyopati tablosunda acil tedavidir. Vakadaki “Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.” ve “Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Purpura ve nörolojik bulgular olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.” ve “Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.” birlikte okunduğunda Plazma değişimi seçeneği öne çıkar; “Dalgalanan bilinç bulanıklığı ve kreatinin yüksekliği organ etkilenimini gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Trombositopeni, mikroanjyopatik hemolitik anemi bulguları, ateş, nörolojik dalgalanma ve böbrek etkilenimi trombotik trombositopenik purpura açısından acil bir tablodur. Tedavi gecikirse mortalite artar; bu nedenle klinik şüphyle plazma değişimi acilen başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı,

“Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.”, “Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.” ve “Dalgalandan bilinç bulanıklığı ve kreatinin yüksekliği organ etkilenimini gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Plazma değişimi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Belirgin trombositopeniyle birlikte peteşi ve ekimozlar vardır.

Kanıt 2: Periferik yaymada şistositler ve yüksek laktat dehidrogenaz mekanik hemolizi destekler.

Kanıt 3: Dalgalandan bilinç bulanıklığı ve kreatinin yüksekliği organ etkilenimini gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Trombotik trombositopenik purpura şüphesinde ADAMTS13 sonucu beklenmeden plazma değişimi başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 15: v164-new-015-dogum-sonrasi-izlem

Başlık: Doğum sonrası izlem

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Rh uygunsuzluğu profilaksisinde doğum sonrası anti-D immünglobulin endikasyonunu belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sorunsuz vajinal doğum sonrası kan grubu uyumsuzluğu açısından değerlendiriliyor. İlk gebeliğini tamamladığı, gebelik boyunca belirgin kanama veya invaziv girişim yaşamadığı öğreniliyor. Daha önce kan transfüzyonu öyküsü yoktur.

Demografi: 26 yaşında kadın hasta | Setting: Doğum sonrası servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 82/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,73

Fizik Muayene

• Anne genel durumu iyi, uterus kontrakte ve vajinal kanaması fizyolojik sınırlardadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Anne kan grubu

Etiket: Anne kan grubu | Tip: bloodBank | Alt tip: Kan bankası | Özet: Rh negatif olarak bildirildi. | Klinik anlam: Profilaksi kararında temel veridir. | Sonuç yorumu: Profilaksi kararında temel veridir. | Sonuç başlığı: Anne kan grubu | Sonuç özeti: Rh negatif olarak bildirildi. | Yorum: Profilaksi kararında temel veridir. | Satırlar: Anne kan grubu / Rh negatif olarak bildirildi. // Profilaksi kararında temel veridir.

Tetkik 2: Yenidoğan kan grubu

Etiket: Yenidoğan kan grubu | Tip: bloodBank | Alt tip: Kan bankası | Özet: Rh pozitif olarak bildirildi. | Klinik anlam: Fetomaternal uyumsuzluk riskini gösterir. | Sonuç yorumu: Fetomaternal uyumsuzluk riskini gösterir. | Sonuç başlığı: Yenidoğan kan grubu | Sonuç özeti: Rh pozitif olarak bildirildi. | Yorum: Fetomaternal uyumsuzluk riskini gösterir. | Satırlar: Yenidoğan kan grubu / Rh pozitif olarak bildirildi. // Fetomaternal uyumsuzluk riskini gösterir.

Tetkik 3: Anne indirekt Coombs testi

Etiket: Anne indirekt Coombs testi | Tip: bloodBank | Alt tip: Kan bankası | Özet: Negatif saptandı. | Klinik anlam: Duyarlanma olmadığını destekler. | Sonuç yorumu: Duyarlanma olmadığını destekler. | Sonuç başlığı: Anne indirekt Coombs testi | Sonuç özeti: Negatif saptandı. | Yorum: Duyarlanma olmadığını destekler. | Satırlar: Anne indirekt Coombs testi / Negatif saptandı. // Duyarlanma olmadığını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada doğum sonrası en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Profilaksi vermeden rutin izlem yapılması
- B) Yenidoğana anti-D immünglobulin uygulanması
- C) Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması
- D) Anneye canlı aşıların ertelenmesi
- E) Anneye exchange transfüzyon yapılması

Doğru Cevap: Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması

A) Profilaksi vermeden rutin izlem yapılması: Profilaksi vermeden izlem yapmak sonraki gebeliklerde alloimmünizasyon riskini azaltmaz ve bu hasta için uygun değildir. Bu olguda “Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.” ve “Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Yenidoğana anti-D immünglobulin uygulanması: Vakadaki Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir ve Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir. Bu olguda “Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.” ve “Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması: Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması fetomaternal geçiş sonrası Rh duyarlanmasını önleyen doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.” ve “Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Anneye canlı aşıların ertelenmesi: Vakadaki Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir ve Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir. Bu olguda “Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.” ve “Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Anneye exchange transfüzyon yapılması: Exchange transfüzyon yenidoğanda ağır hemolitik hastalık gibi durumlarda düşünülür; duyarlanmamış annenin profilaksisi için kullanılmaz. Bu olguda “Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.” ve “Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Doğum sonrası izlem olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.” ve “Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.” birlikte okunduğunda Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması seçeneği öne çıkar; “Anne indirekt Coombs testinin negatif olması duyarlanma gelişmediğini gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Rh negatif ve duyarlanmamış annenin Rh pozitif bebek doğurması, doğum sırasında fetomaternal eritrosit geçişiyle sonraki gebeliklerde alloimmünizasyon riski oluşturur. Bu nedenle anneye doğumdan sonraki 72 saat içinde anti-D immünglobulin verilmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.”, “Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.” ve “Anne indirekt Coombs testinin negatif olması duyarlanma gelişmediğini gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Anneye 72 saat içinde anti-D immünglobulin uygulanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Anne Rh negatif olarak bildirilmiştir.

Kanıt 2: Yenidoğan Rh pozitif olarak bildirilmiştir.

Kanıt 3: Anne indirekt Coombs testinin negatif olması duyarlanma gelişmediğini gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Rh negatif, indirekt Coombs negatif anne Rh pozitif bebek doğursa anti-D immünglobulin anneye ilk 72 saat içinde verilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 16: v164-new-016-akut-skrotal-agri

Başlık: Akut skrotal ağrı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Üroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Testis torsiyonu şüphesinde geciktirilmemesi gereken acil yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan sol testis ağrısı ve bulantı nedeniyle acile getiriliyor. Ağrının spor sonrası istirahat halindeyken aniden başladığı ve giderek şiddetlendiği öğreniliyor. İdrar yaparken yanma, üretral akıntı veya travma öyküsü yoktur.

Demografi: 15 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 0,88

Fizik Muayene

- Sol hemiskrotumda şişlik ve belirgin hassasiyet vardır.
- Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.
- Sol kremaster refleksi alınamamaktadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral antibiyotik verilip poliklinik kontrolü önerilmesi
B) İdrar kültürü sonucuna göre tedavi planlanması
C) Önce Doppler skrotal ultrasonografi ile kan akımını doğrulayıp cerrahiye sonuca göre planlamak
D) Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması
E) Elektif skrotal ultrasonografi randevusu verilmesi

Doğru Cevap: Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması

A) Oral antibiyotik verilip poliklinik kontrolü önerilmesi: Oral antibiyotik epididimoorşitte düşünülebilir ancak ani ağrı, yüksek yerleşimli testis ve kremaster refleksi kaybı varken gecikme testis kaybına yol açabilir. Bu olguda "Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir." ve "Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) İdrar kültürü sonucuna göre tedavi planlanması: Vakadaki Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir ve Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır. Bu olguda "Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir." ve "Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Önce Doppler skrotal ultrasonografi ile kan akımını doğrulayıp cerrahiye sonuca göre planlamak: Vakadaki Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir ve Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır. Bu olguda "Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir." ve "Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması: Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yüksek şüpheli torsiyonda testis perfüzyonunu geri kazandırmak için en uygun ilk yaklaşımdır. Vakadaki "Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir." ve "Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Elektif skrotal ultrasonografi randevusu verilmesi: Elektif ultrasonografi randevusu akut torsiyon şüphesinde kabul edilemez gecikme yaratır; görüntüleme ancak cerrahi kararı geciktirmeyecekse kullanılabilir. Bu olguda "Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir." ve "Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Akut skrotal ağrı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir." ve "Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır." birlikte okunduğunda Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması seçeneği öne çıkar; "Sol kremaster refleksi alınamamaktadır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ani başlayan şiddetli tek taraflı testis ağrısı, bulantı, yüksek yerleşimli transvers testis ve kremaster refleksinin kaybı testis torsiyonu açısından yüksek klinik şüphe oluşturur. Bu durumda testisin canlılığını korumak için görüntüleme veya kültür sonucuyla gecikmeden acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir.", "Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır." ve "Sol kremaster refleksi alınamamaktadır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil cerrahi eksplorasyon ve detorsiyon yapılması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Testis ağrısı aniden başlamış ve hızla şiddetlenmiştir.

Kanıt 2: Sol testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.

Kanıt 3: Sol kremaster refleksi alınamamaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Yüksek klinik şüpheli testis torsiyonunda zaman testis dokusudur; cerrahi eksplorasyon geciktirilmez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 17: v164-new-017-yeni-baslayan-temporal-bas-agrisi

Başlık: Yeni başlayan temporal baş ağrısı

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Romatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Dev hücreli arterit şüphesinde görme kaybını önlemek için ilk tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yeni başlayan şiddetli baş ağrısı ve çiğneme sırasında çene ağrısı nedeniyle başvuruyor. Son üç haftadır halsizlik, iştahsızlık ve saç tararken sağ şakak bölgesinde hassasiyet tarifliyor. Bugün sağ gözde birkaç dakika süren geçici görme bulanıklığı yaşadığını belirtiyor.

Demografi: 72 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 136/78 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 0,62

Fizik Muayene

- Sağ temporal arter trasesinde hassasiyet ve.
- Görme muayenesinde başvuru anında belirgin kalıcı kayıp yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Eritrosit sedimentasyon hızı

Etiket: Eritrosit sedimentasyon hızı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Eritrosit sedimentasyon hızı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Sistemik inflamasyonu destekler. | Satırlar: Eritrosit sedimentasyon hızı / 92 mm/saat / <20 mm/saat / Sistemik inflamasyonu destekler.

Tetkik 2: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aktif inflamatuvar süreci destekler. | Sonuç yorumu: Aktif inflamatuvar süreci destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Aktif inflamatuvar süreci destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 68 mg/L / <5 mg/L / Aktif inflamatuvar süreci destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada görme kaybını önlemek için ilk yapılması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Temporal arter biyopsisi sonucuna göre tedavi planlamak
- B) Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak
- C) Nonsteroid antiinflamatuvar tedavi vermek
- D) Triptan tedavisi başlamak
- E) Oral antibiyotik tedavisi başlamak

Doğru Cevap: Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak

A) Temporal arter biyopsisi sonucuna göre tedavi planlamak: Vakadaki Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır ve Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir. Bu olguda “Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak: Yüksek doz sistemik kortikosteroid görsel iskemi riskini azaltmak için klinik şüphe anında başlanması gereken ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Nonsteroid antiinflamatuvar tedavi vermek: Vakadaki Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır ve Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir. Bu olguda “Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Triptan tedavisi başlamak: Triptan migren atığında kullanılabilir; çene kladikasyonu, temporal arter hassasiyeti ve yüksek sedimentasyonla uyumlu bu vaskülitik tabloyu tedavi etmez. Bu olguda “Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oral antibiyotik tedavisi başlamak: Oral antibiyotik tedavisi enfeksiyon kanıtı olmayan bu inflamatuvar arterit tablosunun uygun ilk tedavisi değildir. Bu olguda “Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yeni başlayan temporal baş ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” birlikte okunduğunda Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak seçeneği öne çıkar; “Geçici görme bulanıklığı ve yüksek inflamatuvar belirteçler mevcuttur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı, çene kladikasyonu, temporal arter hassasiyeti, yüksek inflamatuvar belirteçler ve geçici görsel semptomlar dev hücreli arteriti düşündürür. Kalıcı görme kaybını önlemek için biyopsi planlansa bile tedavi geciktirilmeden yüksek doz sistemik kortikosteroid başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.”, “Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ve “Geçici görme bulanıklığı ve yüksek inflamatuvar belirteçler mevcuttur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Yüksek doz sistemik kortikosteroid başlamak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Yetmiş yaş üzerindeki hastada yeni başlangıçlı temporal baş ağrısı vardır.

Kanıt 2: Çiğneme sırasında çene ağrısı ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.

Kanıt 3: Geçici görme bulanıklığı ve yüksek inflamatuvar belirteçler mevcuttur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Dev hücreli arterit şüphesinde görsel semptom varsa biyopsi beklenmez; kortikosteroid hemen başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 18: v164-new-018-hemoptizi-ve-hematuri-birlikteligi

Başlık: Hemoptizi ve hematüri birlikteliği

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Nefroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Öykü, muayene ve objektif verilerden en olası tanıya ulaşma.

Learning Target: Pulmoner-renal sendromda anti-GBM hastalığını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kanlı balgam, nefes darlığı ve koyu renkli idrar nedeniyle başvuruyor. Son bir haftadır halsizlik ve idrar renginde koyulaşma olduğunu, son iki gündür öksürükle kanlı balgam geldiğini belirtiyor. Bilinen kronik böbrek hastalığı yoktur. Yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ifade ediyor.

Demografi: 24 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 150/92 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %89% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,72

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve dispneik görünümündedir.
- Akciğer oskültasyonunda bilateral ince raller duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar mikroskopisi

Etiket: İdrar mikroskopisi | Tip: microscopy | Alt tip: Mikroskopi | Özet: Eritrosit silendirleri görüldü. | Klinik anlam: Glomerüler kanamayı destekler. | Sonuç yorumu: Glomerüler kanamayı destekler. | Sonuç başlığı: İdrar mikroskopisi | Sonuç özeti: Eritrosit silendirleri görüldü. | Yorum: Glomerüler kanamayı destekler. | Satırlar: İdrar mikroskopisi / Eritrosit silendirleri görüldü. // Glomerüler kanamayı destekler.

Tetkik 2: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut böbrek etkilenimini gösterir. | Sonuç yorumu: Akut böbrek etkilenimini gösterir. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut böbrek etkilenimini gösterir. | Satırlar: Serum kreatinin / 3.1 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Akut böbrek etkilenimini gösterir.

Tetkik 3: Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme

Etiket: Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Glomerüler bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlendi. | Klinik anlam: İmmün birikim paterni ayırıcı tanıda belirleyicidir. | Sonuç yorumu: İmmün birikim paterni ayırıcı tanıda belirleyicidir. | Sonuç başlığı: Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme | Sonuç özeti: Glomerüler bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlendi. | Yorum: İmmün birikim paterni ayırıcı tanıda belirleyicidir. | Satırlar: Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme / Glomerüler bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlendi. // İmmün birikim paterni ayırıcı tanıda belirleyicidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-009 | Başlık: İdrar mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Eritrosit silendirleri görüldü. | Klinik anlam: Glomerüler kanamayı destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/009_009-eritrosit-silendirleri-idrar-mikroskopisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/009_009-eritrosit-silendirleri-idrar-mikroskopisi.webp | Alt text: İdrar mikroskopisi - Eritrosit silendirleri görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-010 | Başlık: Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme | Modalite: microscopy | Bulgu: Glomerüler bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlendi. | Klinik anlam: İmmün birikim paterni ayırıcı tanıda belirleyicidir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/010_010-lineer-igg-birikimi-immunfloresan.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/010_010-lineer-igg-birikimi-immunfloresan.webp | Alt text: Böbrek biyopsisi immünfloresan inceleme - Glomerüler bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anti-glomerüler bazal membran hastalığı
B) IgA nefropatisi
C) Poststreptokokal glomerülofrit
D) Minimal değişiklik hastalığı
E) Diyabetik nefropati

Doğru Cevap: Anti-glomerüler bazal membran hastalığı

A) Anti-glomerüler bazal membran hastalığı: Anti-glomerüler bazal membran hastalığı akciğer kanaması, glomerüler hematüri ve lineer IgG birikimiyle bu olguda en iyi açıklamadır. Vakadaki “Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.” ve “Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) IgA nefropatisi: IgA nefropatisi enfeksiyon sonrası hematüri yapabilir ancak pulmoner hemoraji ve lineer IgG birikimi beklenen temel bulgular değildir. Bu olguda “Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.” ve “Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Anti-glomerüler bazal membran hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Poststreptokokal glomerülofrit: Poststreptokokal glomerülofrit nefritik tablo oluşturabilir ancak tipik olarak granüler immün kompleks birikimiyle seyredir. Bu olguda “Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.” ve “Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Anti-glomerüler bazal membran hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Minimal değişiklik hastalığı: Minimal değişiklik hastalığı nefrotik sendromla ilişkilidir; eritrosit silendirleri, hemoptizi ve lineer IgG paterni bu tanıya uymaz. Bu olguda “Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.” ve “Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Anti-glomerüler bazal membran hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Diyabetik nefropati: Diyabetik nefropati kronik proteinüri ve diyabet öyküsüyle beklenir; akut pulmoner-renal sendromu ve lineer IgG bulgusunu açıklamaz. Bu olguda “Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.” ve “Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Anti-glomerüler bazal membran hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hemoptizi ve hematüri birlikteliği olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.” ve “Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.” birlikte okunduğunda Anti-glomerüler bazal membran hastalığı seçeneği öne çıkar; “İmmünfloresan incelemede bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hemoptizi, hipoksemi, hematüri, eritrosit silendirleri ve akut kreatinin yüksekliği pulmoner-renal sendromu düşündürür. Böbrek biyopsisinde glomerüler bazal membran boyunca lineer IgG birikimi anti-glomerüler bazal membran hastalığı için karakteristiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.”, “Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.” ve “İmmünfloresan incelemede bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Anti-glomerüler bazal membran hastalığı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanlı balgam ve hipoksemi akciğer tutulumu olduğunu gösterir.

Kanıt 2: Koyu renkli idrar ve eritrosit silendirleri glomerüler kanamayı destekler.

Kanıt 3: İmmünfloresan incelemede bazal membran boyunca lineer IgG birikimi izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından

doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Pulmoner hemoraji ve hızlı böbrek bozulmasıyla birlikte lineer IgG birikimi anti-glomerüler bazal membran hastalığını düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 19: v164-new-019-ilac-sonrasi-ajitasyon-ve-ates

Başlık: İlaç sonrası ajitasyon ve ateş

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Psikiyatri / Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Serotonin sendromunda klinik bulgulara göre uygun tedavi yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ajitasyon, terleme, ishal ve ateş nedeniyle acile getiriliyor. Depresyon nedeniyle selektif serotonin geri alım inhibitörü kullandığı, iki gün önce dirençli enfeksiyon nedeniyle linezolid başlandığı öğreniliyor. Yakınları hastanın bugün huzursuzlaştığını, titredüğünü ve sık dışkılama yaşadığını belirtiyor.

Demografi: 39 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 156/88 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 39.0°C | Şok indeksi: 0,82

Fizik Muayene

- Hasta ajite ve diaforetikdir.
- Alt ekstremitelerde belirgin hiperrefleksi ve spontan klonus vardır.
- Pupiller dilatedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kreatin kinaz

Etiket: Serum kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hafif yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kas aktivitesi ve hipertermiye eşlik edebilir. | Sonuç yorumu: Kas aktivitesi ve hipertermiye eşlik edebilir. | Sonuç başlığı: Serum kreatin kinaz | Sonuç özeti: Hafif yüksek saptandı. | Yorum: Kas aktivitesi ve hipertermiye eşlik edebilir. | Satırlar: Serum kreatin kinaz / 520 U/L / 30-200 U/L / Kas aktivitesi ve hipertermiye eşlik edebilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antipsikotik dozunu artırmak
- B) Dopamin agonisti başlamak
- C) Asetilkolinesteraz inhibitörü vermek
- D) Lityum tedavisine başlamak
- E) Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek

Doğru Cevap: Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek

A) Antipsikotik dozunu artırmak: Antipsikotik dozunu artırmak serotonin fazlalığını düzeltmez ve hipertermi ile otonom instabiliteyi kötüleştirir. Bu olguda "Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır." ve "Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Dopamin agonisti başlamak: Dopamin agonisti nöroleptik malign sendromda düşünülebilir; bu olguda ilaç etkileşimi, ishal, hiperrefleksi ve klonus serotonerjik toksisiteyi destekler. Bu olguda "Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır." ve "Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Asetilkolinesteraz inhibitörü vermek: Asetilkolinesteraz inhibitörü kolinerjik etkiyi artırır ve bu hastadaki serotonerjik toksisite mekanizmasını tedavi etmez. Bu olguda "Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır." ve "Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Lityum tedavisine başlamak: Lityum tedavisi duygudurum bozukluklarında kullanılabilir ancak akut ajitasyon, hiperrefleksi ve klonusla seyreden ilaç toksisitesinde uygun değildir. Bu olguda "Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır." ve "Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir." ipuçları tedavi önceliği açısından Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek: Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek, bu hastadaki serotonerjik aşırı aktiviteyi hedefleyen en uygun yaklaşımdır. Vakadaki "Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır." ve "Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: İlaç sonrası ajitasyon ve ateş olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır." ve "Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir." birlikte okunduğunda Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek seçeneği öne çıkar; "Hiperrefleksi ve spontan klonus nöromüsküler aşırı uyarılmayı destekler." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Selektif serotonin geri alım inhibitörü ile linezolid birlikteliği sonrası ajitasyon, otonom hiperaktivite, ishal, hiperrefleksi ve klonus serotonin fazlalığına bağlı toksisiteyi düşündürür. Tedavide sorumlu serotonerjik ilaçlar kesilir, destek tedavisi uygulanır ve orta-ağır olgularda serotonin antagonisti olan siproheptadin verilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır.", "Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir." ve "Hiperrefleksi ve spontan klonus nöromüsküler aşırı uyarılmayı destekler." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Serotonerjik ilaçları kesip destek tedavisi ve siproheptadin vermek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Selektif serotonin geri alım inhibitörü kullanırken linezolid başlanmıştır.

Kanıt 2: Ajitasyon, terleme, ateş, taşikardi ve hipertansiyon otonom aktivasyonu gösterir.

Kanıt 3: Hiperrefleksi ve spontan klonus nöromüsküler aşırı uyarılmayı destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Serotonin sendromunda klonus ve hiperrefleksi ayırt edicidir; temel yaklaşım serotonerjik ajanları kesmek ve destek tedavisidir.

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 20: v164-new-020-antibiyotik-sonrasi-ishal

Başlık: Antibiyotik sonrası ishal

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Enfeksiyon Hastalıkları / Gastroenteroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Clostridioides difficile kolitinde klinik bağlam ve dışkı testiyle uygun tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, hastanede yatarken gelişen sulu ishal ve karın ağrısı nedeniyle değerlendiriliyor. Pnömoni nedeniyle son 8 gündür geniş spektrumlu antibiyotik kullandığı öğreniliyor. Son 24 saatte 8 kez sulu dışkılama, kramp tarzında karın ağrısı ve iştahsızlık tarifliyor. Kanlı dışkılama belirtmiyor.

Demografi: 67 yaşında erkek hasta | Setting: Dahiliye servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/70 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta hafif toksik görünümündedir.
- Batında yaygın hassasiyet vardır, rebound yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lökositoz saptandı. | Klinik anlam: İnflamatuvar enfeksiyöz tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: İnflamatuvar enfeksiyöz tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lökositoz saptandı. | Yorum: İnflamatuvar enfeksiyöz tabloyu destekler. | Satırlar: Tam kan sayımı / 16.400 /mm³ / 4.500-11.000 /mm³ / İnflamatuvar enfeksiyöz tabloyu destekler.

Tetkik 2: Dışkıda toksin testi

Etiket: Dışkıda toksin testi | Tip: culture | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Toksin pozitif bulundu. | Klinik anlam: Antibiyotik ilişkili kolit etkenini destekler. | Sonuç yorumu: Antibiyotik ilişkili kolit etkenini destekler. | Sonuç başlığı: Dışkıda toksin testi | Sonuç özeti: Toksin pozitif bulundu. | Yorum: Antibiyotik ilişkili kolit etkenini destekler. | Satırlar: Dışkıda toksin testi / Toksin pozitif bulundu. // Antibiyotik ilişkili kolit etkenini destekler.

Tetkik 3: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Başlangıca göre belirgin artış yok. | Klinik anlam: Ağır komplike tablo lehine belirgin böbrek bozulması yoktur. | Sonuç yorumu: Ağır komplike tablo lehine belirgin böbrek bozulması yoktur. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Başlangıca göre belirgin artış yok. | Yorum: Ağır komplike tablo lehine belirgin böbrek bozulması yoktur. | Satırlar: Serum kreatinin / 1.0 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Ağır komplike tablo lehine belirgin böbrek bozulması yoktur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Loperamid başlanması
B) Oral vankomisin tedavisi başlanması
C) Probiyotik ile izlem yapılması
D) İntravenöz aminoglikozid başlanması
E) Acil kolektomi yapılması

Doğru Cevap: Oral vankomisin tedavisi başlanması

A) Loperamid başlanması: Loperamid toksin retansiyonunu artırabileceği için inflamatuvar antibiyotik ilişkili kolitte uygun tedavi değildir. Bu olguda “Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oral vankomisin tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Oral vankomisin tedavisi başlanması: Vakadaki Hasta geniş spektrumlu barsak lümenindeki toksin üreten etkeni hedeflediği için bu tabloda uygun tedavi seçeneğidir. Vakadaki “Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Probiyotik ile izlem yapılması: Vakadaki Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir ve Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler. Bu olguda “Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oral vankomisin tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) İntravenöz aminoglikozid başlanması: İntravenöz aminoglikozid barsak lümenindeki toksin ilişkili kolit için uygun hedeflenmiş tedavi sağlamaz. Bu olguda “Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oral vankomisin tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Acil kolektomi yapılması: Acil kolektomi toksik megakolon, perforasyon veya tedaviye yanıtız fulminan hastalıkta düşünülür; bu olguda böyle bir karar bağlamı verilmemiştir. Bu olguda “Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oral vankomisin tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antibiyotik sonrası ishal olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” birlikte okunduğunda Oral vankomisin tedavisi başlanması seçeneği öne çıkar; “Dışkıda toksin testi pozitif bulunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yakın dönem geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, hastane yatışı, sulu ishal, ateş, lökositoz ve dışkıda toksin pozitifliği Clostridioides difficile enfeksiyonunu düşündürür. Komplike fulminan bulgular olmadan uygun ilk tedavi oral vankomisin veya fidaksomisin gibi barsak lümeninde etkili tedavidir; seçenekler içinde oral vankomisin en uygundur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.”, “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ve “Dışkıda toksin testi pozitif bulunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oral vankomisin tedavisi başlanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sırasında hastanede sulu ishal geliştirmiştir.

Kanıt 2: Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.

Kanıt 3: Dışkıda toksin testi pozitif bulunmuştur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Antibiyotik sonrası toksin pozitif sulu ishalde tedavi barsak lümenine etkili oral ajanla yapılır; antitomotilite ilaçlarından kaçınılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 21: v165-new-021-acilik-ve-kusma-sonrasi-metabolik-bozulma

Başlık: Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Endokrinoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Diyabetik ketoasidozda hipokalemi varlığında insülin tedavisinin zamanlamasını belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tekrarlayan kusma, karın ağrısı ve derin hızlı solunum nedeniyle acile getiriliyor. Son iki haftadır çok su içme, sık idrara çıkma ve kilo kaybı olduğu, son 24 saatte bulantı ve kusmanın belirginleştiği öğreniliyor. Bilinen diyabet öyküsü yoktur.

Demografi: 17 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 95/60 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,28 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta halsiz ve dehidrate görünümündedir.
- Mukozalar kurudur, solunumu derin ve hızlıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma glukozu

Etiket: Plazma glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hiperglisemik acil tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Hiperglisemik acil tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma glukozu | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hiperglisemik acil tabloyu destekler. | Satırlar: Plazma glukozu / 486 mg/dL / 70-140 mg/dL | Hiperglisemik acil tabloyu destekler.

Tetkik 2: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Asidozun derecesini gösterir. | Sonuç yorumu: Asidozun derecesini gösterir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Asidozun derecesini gösterir. | Satırlar: Arter kan gazı / 7.12 / 7.35-7.45 / Asidozun derecesini gösterir.

Tetkik 3: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: İnsülin başlanmadan önce kritik karar değiştirici bulgudur. | Sonuç yorumu: İnsülin başlanmadan önce kritik karar değiştirici bulgudur. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: İnsülin başlanmadan önce kritik karar değiştirici bulgudur. | Satırlar: Serum potasyum / 3.0 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L | İnsülin başlanmadan önce kritik karar değiştirici bulgudur.

Tetkik 4: İdrar ketonu

Etiket: İdrar ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Ketotik metabolik tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Ketotik metabolik tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: İdrar ketonu | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Ketotik metabolik tabloyu destekler. | Satırlar: İdrar ketonu / Pozitif saptandı. | Ketotik metabolik tabloyu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-252 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Mukozalar kurudur, solunumu derin ve hızlıdır | Klinik anlam: İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/252_concerned_patient_in_hospital_bed.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/252_concerned_patient_in_hospital_bed.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Mukozalar kurudur, solunumu derin ve hızlıdır | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) Hemen intravenöz insülin infüzyonu başlamak
- B) Subkütan hızlı etkili insülin uygulamak
- C) Sodyum bikarbonat infüzyonunu ilk tedavi olarak vermek
- D) İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek
- E) Potasyum düzeyi düzeltilmeden intravenöz insülin infüzyonunu hızlandırmak

Doğru Cevap: İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek

- A) Hemen intravenöz insülin infüzyonu başlamak: Hemen intravenöz insülin infüzyonu potasyum düşüken aritmi riskini artıracığı için bu olguda güvenli ilk basamak değildir. Bu olguda “Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.” ve “Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Subkütan hızlı etkili insülin uygulamak: Vakadaki Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir ve Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür. Bu olguda “Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.” ve “Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Sodyum bikarbonat infüzyonunu ilk tedavi olarak vermek: Sodyum bikarbonat yalnızca seçilmiş çok ağır asidoz durumlarında düşünülür; bu hastada ilk kritik eksiklik sıvı ve potasyumdur. Bu olguda “Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.” ve “Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek: İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı, düşük potasyum nedeniyle insülinin geçici olarak ertelenmesi gereken bu hastada en doğru ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.” ve “Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- E) Potasyum düzeyi düzeltilmeden intravenöz insülin infüzyonunu hızlandırmak: Vakadaki Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir ve Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür. Bu olguda “Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.” ve “Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlık ve kusma sonrası metabolik bozulma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.” ve “Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.” birlikte okunduğunda İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek seçeneği öne çıkar; “Serum potasyumunun 3.0 mmol/L olması insülinin hemen başlanmasını riskli hale getirir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hasta hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidozla ketoasidotik acil tabloya sahiptir; ancak serum potasyumu düşüktür. İnsülin potasyumu hücre içine kaydırarak ağır aritmi riskini artırabileceği için önce damar içi sıvı ve potasyum replasmanı yapılmalı, insülin potasyum güvenli düzeye çıktıktan sonra başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.”, “Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.” ve “Serum potasyumunun 3.0 mmol/L olması insülinin hemen başlanmasını riskli hale getirir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İzotonik sıvı ve potasyum replasmanı başlamak, insülini potasyum düzeleneye kadar ertelemek

en tutarlı yanittır.

Kanıt 1: Hiperglisemi, ketonüri ve metabolik asidoz birlikte ketotik acil metabolik tabloyu gösterir.

Kanıt 2: Kuru mukozalar, taşikardi ve düşük kan basıncı belirgin sıvı açığını düşündürür.

Kanıt 3: Serum potasyumunun 3.0 mmol/L olması insülinin hemen başlanmasını riskli hale getirir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ketoasidotik acilde potasyum düşükse insülin ertelenir; önce sıvı ve potasyum replasmanı yapılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 22: v165-new-022-erken-donemde-sarilik

Başlık: Erken dönemde sarılık

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Neonatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Yenidoğanda erken indirekt hiperbilirubinemi ve hemolizde alta yatan immün mekanizmayı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebekte doğumdan sonraki ilk iki gün içinde belirginleşen sarılık nedeniyle değerlendirme isteniyor. Term doğduğu, doğum ağırlığının uygun olduğu ve emmesinin hafif azaldığı öğreniliyor. Annenin kan grubunun O Rh pozitif, bebeğin kan grubunun A Rh pozitif olduğu belirtiliyor.

Demografi: 36 saatlik erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 142/dk | Solunum: 44/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,03 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebekte yüz ve gövdede sarılık izlenmektedir.
- Karaciğer ve dalak belirgin büyümemiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Total bilirubin

Etiket: Total bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yaşa göre yüksek saptandı. | Klinik anlam: Erken dönemde dikkat gerektiren indirekt bilirubin artışını destekler. | Sonuç yorumu: Erken dönemde dikkat gerektiren indirekt bilirubin artışını destekler. | Sonuç başlığı: Total bilirubin | Sonuç özeti: Yaşa göre yüksek saptandı. | Yorum: Erken dönemde dikkat gerektiren indirekt bilirubin artışını destekler. | Satırlar: Total bilirubin / 12.8 mg/dL / Yaşa ve risk faktörlerine göre değerlendirilir / Erken dönemde dikkat gerektiren indirekt bilirubin artışını destekler.

Tetkik 2: Direkt bilirubin

Etiket: Direkt bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek değildir. | Klinik anlam: Konjuge hiperbilirubinemi ön planda değildir. | Sonuç yorumu: Konjuge hiperbilirubinemi ön planda değildir. | Sonuç başlığı: Direkt bilirubin | Sonuç özeti: Belirgin yüksek değildir. | Yorum: Konjuge hiperbilirubinemi ön planda değildir. | Satırlar: Direkt bilirubin / 0.4 mg/dL / <1.0 mg/dL / Konjuge hiperbilirubinemi ön planda değildir.

Tetkik 3: Direkt antiglobulin testi

Etiket: Direkt antiglobulin testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Eritrosit yüzeyinde antikor varlığını destekler. | Sonuç yorumu: Eritrosit yüzeyinde antikor varlığını destekler. | Sonuç başlığı: Direkt antiglobulin testi | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Eritrosit yüzeyinde antikor varlığını destekler. | Satırlar: Direkt antiglobulin testi / Pozitif saptandı. // Eritrosit yüzeyinde antikor varlığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-253 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Bebekte yüz ve gövdede sarılık izlenmektedir | Klinik anlam: Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/253_newborn_resting_in_hospital_care.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/253_newborn_resting_in_hospital_care.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Bebekte yüz ve gövdede sarılık izlenmektedir | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte sarılığın temel mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Safra kanal tıkanıklığına bağlı konjuge bilirubin atılımının azalması
- B) Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması
- C) Hepatositlerde bilirubin konjugasyonunun tamamen yok olması
- D) Anne sütündeki maddelere bağlı geç başlangıçlı enterohepatik dolaşım artışı
- E) Eritrosit membran protein kusuruna bağlı kronik sferosit yıkımı

Doğru Cevap: Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması

A) Safra kanal tıkanıklığına bağlı konjuge bilirubin atılımının azalması: Safra kanal tıkanıklığında direkt bilirubin artışı beklenir; bu olguda direkt bilirubin belirgin yüksek değildir. Bu olguda “Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.” ve “Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması: Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması, ABO uyumsuzluğu ve pozitif direkt antiglobulin testiyle en uyumlu mekanizmadır. Vakadaki “Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.” ve “Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

C) Hepatositlerde bilirubin konjugasyonunun tamamen yok olması: Bilirubin konjugasyonunun tamamen yok olması daha ağır kalıtsal konjugasyon bozukluklarını düşündürür; burada immün hemoliz kanıtı vardır. Bu olguda “Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.” ve “Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Anne sütündeki maddelere bağlı geç başlangıçlı enterohepatik dolaşım artışı: Anne sütü sarılığı genellikle daha geç dönemde belirginleşir ve pozitif direkt antiglobulin testiyle açıklanmaz. Bu olguda “Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.” ve “Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Eritrosit membran protein kusuruna bağlı kronik sferosit yıkımı: Eritrosit membran protein kusuru kronik hemoliz yapabilir ancak anne-bebek kan grubu uyumsuzluğu ve antikor pozitifliği bu olguda daha belirleyicidir. Bu olguda “Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.” ve “Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken dönemde sarılık olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.” ve “Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu

vardır.” birlikte okunduğunda Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması seçeneği öne çıkar; “Direkt antiglobulin testinin pozitif olması eritrosit yüzeyinde antikor varlığını gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İlk 24-48 saatte belirginleşen indirekt bilirubin artışı, anne-bebek ABO uyumsuzluğu ve direkt antiglobulin testinin pozitif olması immün aracılı hemolizi düşündürür. Maternal immünoglobulin G antikorları plasentayı geçerek yenidoğan eritrositlerine bağlanır ve bilirubin yükünü artıran hemolize yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.”, “Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu vardır.” ve “Direkt antiglobulin testinin pozitif olması eritrosit yüzeyinde antikor varlığını gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Maternal immünoglobulin G antikorlarının fetal eritrositleri hemolize uğratması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Sarılığın yaşamın ilk iki günü içinde belirginleşmesi fizyolojik sarılıktan daha erken bir süreci düşündürür.

Kanıt 2: Anne ve bebek kan grupları arasında ABO uyumsuzluğu vardır.

Kanıt 3: Direkt antiglobulin testinin pozitif olması eritrosit yüzeyinde antikor varlığını gösterir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Yenidoğanda erken indirekt sarılık ve pozitif direkt antiglobulin testi immün hemolizi akla getirir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 23: v165-new-023-dogum-sonrasi-aktif-kanama

Başlık: Doğum sonrası aktif kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Postpartum kanamada uterin atoniye yönelik ilk tedavi basamağını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, normal vajinal doğumdan kısa süre sonra devam eden yoğun vajinal kanama nedeniyle değerlendiriliyor. Doğumun uzamış eylem sonrası gerçekleştiği, plasentanın tam olarak ayrıldığı ve daha önce bilinen kanama bozukluğu olmadığı öğreniliyor. Gebelikte çoğul gebelik veya plasenta anomalisi bildirilmemiştir.

Demografi: 27 yaşında kadın hasta | Setting: Doğumhane

Vital Bulgular

Kan basıncı: 90/55 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,31 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve huzursuzdur.
- Uterus fundusu göbek hizasında yumuşak ve gevşek palpe edilmektedir.
- Vajinal muayenede belirgin servikal veya vajinal laserasyon izlenmemektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tahmini kan kaybı

Etiket: Tahmini kan kaybı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Doğum sonrası kısa sürede yaklaşık 900 mL kanama izlendi. | Klinik anlam: Doğum sonrası kanama açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Doğum sonrası kanama açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Tahmini kan kaybı | Sonuç özeti: Doğum sonrası kısa sürede yaklaşık 900 mL kanama izlendi. | Yorum: Doğum sonrası kanama açısından anlamlıdır. | Satırlar: Tahmini kan kaybı / 900 mL / / Doğum sonrası kanama açısından anlamlıdır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada kanamayı kontrol etmek için ilk uygulanması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması
- B) Acil histerektomi yapılması
- C) Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılması
- D) Metotreksat tedavisi başlanması
- E) Geniş spektrumlu antibiyotik başlanması

Doğru Cevap: Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması

A) Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması: Uterin masaj ve intravenöz oksitosin gevşek uterusun kasılmasını sağlayarak bu Vakadaki kanama mekanizmasını doğrudan hedefler. Vakadaki “Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Acil histerektomi yapılması: Acil histerektomi hayatı tehdit eden ve konservatif tedavilere yanıtız kanamalarda düşünülür; ilk basamak değildir. Bu olguda “Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılması: Vakadaki Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır ve Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir. Bu olguda “Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Metotreksat tedavisi başlanması: Metotreksat ektrauterin gebelik gibi farklı durumlarda kullanılır; doğum sonrası gevşek uterus kaynaklı kanamada yeri yoktur. Bu olguda “Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Geniş spektrumlu antibiyotik başlanması: Geniş spektrumlu antibiyotik enfeksiyon şüphesinde gerekebilir ancak bu hastadaki akut kanamanın ilk kontrol tedavisi değildir. Bu olguda “Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Doğum sonrası aktif kanama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.” birlikte okunduğunda Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması seçeneği öne çıkar; “Belirgin doğum yolu laserasyonu izlenmemesi kanamanın uterus kaynaklı olasılığını artırır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Doğum sonrası yoğun kanama, yumuşak ve gevşek uterus fundusu ile belirgin laserasyon olmaması uterin atoniye düşündürür. İlk tedavi uterusun kasılmasını sağlamak için uterin masaj ve oksitosindir; kan replasmanı destekleyici olabilir ancak kanamanın kaynağını düzeltmez. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.”, “Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.” ve “Belirgin doğum yolu laserasyonu izlenmemesi kanamanın uterus kaynaklı olasılığını artırır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle

Uterin masaj ve intravenöz oksitosin uygulaması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanama normal vajinal doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Uterus fundusunun yumuşak ve gevşek olması kasılma yetersizliğini gösterir.

Kanıt 3: Belirgin doğum yolu laserasyonu izlenmemesi kanamanın uterus kaynaklı olasılığını artırır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Postpartum kanamada gevşek ve yumuşak uterus varsa ilk yaklaşım uterin masaj ve oksitosindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 24: v165-new-024-ates-ve-yeni-ufurum

Başlık: Ateş ve yeni üfürüm

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Enfeksiyon Hastalıkları / Kardiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik bağlam ve mikrobiyolojik ipuçlarıyla olası etkeni belirleme.

Learning Target: İntravenöz madde kullanımıyla ilişkili sağ kalp endokarditinde en olası etkeni seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, üşüme-titreme ve nefes darlığı nedeniyle acil servise başvuruyor. Yaklaşık bir haftadır yüksek ateş ve halsizlik olduğunu, son günlerde öksürükle birlikte göğüs ağrısının geliştiğini belirtiyor. İntravenöz madde kullanım öyküsü vardır.

Demografi: 34 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 105/65 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 39.2°C | Şok indeksi: 1,18 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta toksik görünümündedir.
- Sternum sol alt kenarında sistolik üfürüm duyulur.
- Akciğer oskültasyonunda dağınık raller mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan kültürü Gram boyama

Etiket: Kan kültürü Gram boyama | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Gram-pozitif kok kümeleri görüldü. | Klinik anlam: Etkenin morfolojik sınıflandırılması için önemlidir. | Sonuç yorumu: Etkenin morfolojik sınıflandırılması için önemlidir. | Sonuç başlığı: Kan kültürü Gram boyama | Sonuç özeti: Gram-pozitif kok kümeleri görüldü. | Yorum: Etkenin morfolojik sınıflandırılması için önemlidir. | Satırlar: Kan kültürü Gram boyama / Gram-pozitif kok kümeleri görüldü. // Etkenin morfolojik sınıflandırılması için önemlidir.

Tetkik 2: Transtorasik ekokardiyografi

Etiket: Transtorasik ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: Kapak enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Kapak enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Transtorasik ekokardiyografi | Sonuç özeti: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Yorum: Kapak enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Transtorasik ekokardiyografi | Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. // Kapak enfeksiyonunu destekler.

Tetkik 3: Toraks bilgisayarlı tomografisi

Etiket: Toraks bilgisayarlı tomografisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Her iki akciğerde periferik nodüler ve kaviter lezyonlar izlendi. | Klinik anlam: Sağ kalp kaynaklı embolik yayılımı düşündürür. | Sonuç yorumu: Sağ kalp kaynaklı embolik yayılımı düşündürür. | Sonuç başlığı: Toraks bilgisayarlı tomografisi | Sonuç özeti: Her iki akciğerde periferik nodüler ve kaviter lezyonlar izlendi. | Yorum: Sağ kalp kaynaklı embolik yayılımı düşündürür. | Satırlar: Toraks bilgisayarlı tomografisi / Her iki akciğerde periferik nodüler ve kaviter lezyonlar izlendi. // Sağ kalp kaynaklı embolik yayılımı düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-011 | Başlık: Kan kültürü Gram boyama | Modalite: microscopy | Bulgu: Gram-pozitif kok kümeleri görüldü. | Klinik anlam: Etkenin morfolojik sınıflandırılması için önemlidir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/011_011-gram-pozitif-kok-kumeleri-gram-boyama.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/011_011-gram-pozitif-kok-kumeleri-gram-boyama.webp | Alt text: Kan kültürü Gram boyama - Gram-pozitif kok kümeleri görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-012 | Başlık: Transtorasik ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: Kapak enfeksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/012_012-trikuspit-vejetasyon-ekokardiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/012_012-trikuspit-vejetasyon-ekokardiyografi.webp | Alt text: Transtorasik ekokardiyografi - Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 3: ID: visual-013 | Başlık: Toraks bilgisayarlı tomografisi | Modalite: ct | Bulgu: Her iki akciğerde periferik nodüler ve kaviter lezyonlar izlendi. | Klinik anlam: Sağ kalp kaynaklı embolik yayılımı düşündürür. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/013_013-septik-pulmoner-emboli-toraks-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/013_013-septik-pulmoner-emboli-toraks-bt.webp | Alt text: Toraks bilgisayarlı tomografisi - Her iki akciğerde periferik nodüler ve kaviter lezyonlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Streptococcus viridans
- B) Staphylococcus epidermidis
- C) Staphylococcus aureus
- D) Enterococcus faecalis
- E) Coxiella burnetii

Doğru Cevap: Staphylococcus aureus

A) Streptococcus viridans: Streptococcus viridans daha çok dental kaynaklı subakut doğaal kapak endokarditiyle ilişkilidir; bu olguda akut tablo ve gram-pozitif kok kümeleri ön plandadır. Bu olguda "İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır." ve "Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir." ipuçları tanısall karara açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Staphylococcus epidermidis: Staphylococcus epidermidis protez kapak ve kateter ilişkili enfeksiyonlarda önemlidir; intravenöz madde kullanımıyla gelişen akut triküspit tutulumunda en olası etken değildir. Bu olguda "İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır." ve "Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir." ipuçları tanısall karara açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus intravenöz madde kullanımı, triküspit kapak vejetasyonu, gram-pozitif kok kümeleri ve septik pulmoner emboliyle en uyumlu etkidir. Vakadaki "İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır." ve "Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

D) Enterococcus faecalis: Enterococcus faecalis genitouriner veya gastrointestinal girişim sonrası endokardit yapabilir; verilen risk profili ve Gram boyama paterni daha farklıdır. Bu olguda "İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır." ve "Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir." ipuçları tanısall karara açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Coxiella burnetii: Coxiella burnetii kültür negatif endokardit etkenidir; bu hastada kan kültürü Gram boyamada kok kümeleri görülmesi bu seçeneği geri plana iter. Bu olguda “İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir.” ipuçları tanısar karar açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve yeni üfürüm olgusunda klinik karar tanısar karar üzerine kuruludur. “İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir.” birlikte okunduğunda Staphylococcus aureus seçeneği öne çıkar; “Periferik kaviter akciğer lezyonları embolik enfeksiyöz yayılımla uyumludur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İntravenöz madde kullanımı olan hastada ateş, triküspit vejetasyon, septik pulmoner emboli bulguları ve gram-pozitif kok kümeleri akut sağ kalp endokarditini düşündürür. Bu klinik bağlamda en olası etken Staphylococcus aureus'tur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır.”, “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir.” ve “Periferik kaviter akciğer lezyonları embolik enfeksiyöz yayılımla uyumludur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Staphylococcus aureus en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: İntravenöz madde kullanım öyküsü doğrudan kan dolaşımı enfeksiyonu riskini artırır.

Kanıt 2: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon sağ kalp kapak tutulumunu gösterir.

Kanıt 3: Periferik kaviter akciğer lezyonları embolik enfeksiyöz yayılımla uyumludur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: İntravenöz madde kullanıcısında triküspit kapak endokarditi ve septik pulmoner emboli en çok Staphylococcus aureus ile ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 25: v165-new-025-yukselen-gucsuzluk-tablosu

Başlık: Yükselen güçsüzlük tablosu

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Nöroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Guillain-Barré sendromunda solunum riski olan hastada immün tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerleyen güçsüzlük nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki hafta önce sulu ishal geçirdiğini, son dört gündür merdiven çıkmakta zorlandığını ve bugün ellerinde de güçsüzlük başladığını belirtiyor. İdrar-gaita kontrolünde belirgin sorun tariflemiyor.

Demografi: 28 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %95% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Bilateral alt ekstremitte kas gücü 3/5, üst ekstremitte kas gücü 4/5 olarak değerlendirilmiştir.
- Derin tendon refleksleri yaygın azalmıştır.
- Duyu muayenesinde hafif distal parestezi vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyin omurilik sıvısı analizi

Etiket: Beyin omurilik sıvısı analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Protein yüksek, hücre sayısı normal sınırlarda saptandı. | Klinik anlam: Albuminositolojik ayrışmayı destekler. | Sonuç yorumu: Albuminositolojik ayrışmayı destekler. | Sonuç başlığı: Beyin omurilik sıvısı analizi | Sonuç özeti: Protein yüksek, hücre sayısı normal sınırlarda saptandı. | Yorum: Albuminositolojik ayrışmayı destekler. | Satırlar: Beyin omurilik sıvısı analizi / Protein yüksek, hücre sayısı normal sınırlarda saptandı. // Albuminositolojik ayrışmayı destekler.

Tetkik 2: Zorlu vital kapasite ölçümü

Etiket: Zorlu vital kapasite ölçümü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yaşa göre azalmış bulundu. | Klinik anlam: Solunum kası etkilenişi açısından yakın izlem gerektirir. | Sonuç yorumu: Solunum kası etkilenişi açısından yakın izlem gerektirir. | Sonuç başlığı: Zorlu vital kapasite ölçümü | Sonuç özeti: Yaşa göre azalmış bulundu. | Yorum: Solunum kası etkilenişi açısından yakın izlem gerektirir. | Satırlar: Zorlu vital kapasite ölçümü / Yaşa göre azalmış bulundu. // Solunum kası etkilenişi açısından yakın izlem gerektirir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-254 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Derin tendon refleksleri yaygın azalmıştır | Klinik anlam: İntravenöz immüno globulin | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/254_exhausted_in_the_er_room.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/254_exhausted_in_the_er_room.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Derin tendon refleksleri yaygın azalmıştır | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hastalık seyrini değiştirmeye yönelik en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yüksek doz oral kortikosteroid
- B) İntravenöz immüno globulin
- C) Dopamin agonisti
- D) Asetilkolinesteraz inhibitörü
- E) Kontrol tedavisi olarak antibiyotik profilaksisi

Doğru Cevap: İntravenöz immüno globulin

A) Yüksek doz oral kortikosteroid: Yüksek doz oral kortikosteroid bu tabloda hastalık seyrini düzelter standart tedavi değildir ve immüno globulin yerine kullanılmaz. Bu olguda “Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.” ve “Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immüno globulin seçeneğini daha güçlü kılar.

B) İntravenöz immüno globulin: İntravenöz immüno globulin ilerleyici güçsüzlük ve solunum riski olan bu hastada hastalık seyrini değiştiren uygun immün tedavidir. Vakadaki “Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.” ve “Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Dopamin agonisti: Dopamin agonisti parkinsonizm gibi bazal gangliyon hastalıklarında kullanılır; akut periferik demiyelinizan güçsüzlük tablosunu tedavi etmez. Bu olguda “Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.” ve “Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immüno globulin seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Asetilkolinesteraz inhibitörü: Asetilkolinesteraz inhibitörü nöromusküler kavşak hastalıklarında yararlı olabilir; arefleksi ve albuminositolojik ayrışmayla giden bu olguda uygun değildir. Bu olguda “Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.” ve “Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünoglobulin seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kontrol tedavisi olarak antibiyotik profilaksisi: Vakadaki Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir ve Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür. Bu olguda “Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.” ve “Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünoglobulin seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yükselen güçsüzlük tablosu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.” ve “Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.” birlikte okunduğunda İntravenöz immünoglobulin seçeneği öne çıkar; “Beyin omurilik sıvısında protein yüksekliği ve normal hücre sayısı saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İshal sonrası gelişen yükselen simetrik güçsüzlük, arefleksi ve albuminositolojik ayrışma Guillain-Barré sendromunu destekler. Solunum kapasitesinde azalma varsa hasta yakından izlenmeli ve hastalık seyrini değiştirmek için intravenöz immünoglobulin veya plazmaferez verilmelidir; seçenekler içinde uygun tedavi intravenöz immünoglobulindir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.”, “Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.” ve “Beyin omurilik sıvısında protein yüksekliği ve normal hücre sayısı saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz immünoglobulin en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Güçsüzlük bacaklardan başlayıp kollara doğru ilerlemiştir.

Kanıt 2: Derin tendon reflekslerinin yaygın azalması periferik sinir kökü tutulumunu düşündürür.

Kanıt 3: Beyin omurilik sıvısında protein yüksekliği ve normal hücre sayısı saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Guillain-Barré sendromunda etkili immün tedaviler intravenöz immünoglobulin ve plazmaferezdir; solunum fonksiyonu mutlaka izlenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 26: v165-new-026-bradikardi-ve-hipotansiyon

Başlık: Bradikardi ve hipotansiyon

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Farmakoloji / Acil Tıp | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Beta bloker zehirlenmesinde glukagonun etki mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi ve belirgin halsizlik nedeniyle acile getiriliyor. Yakınları hastanın birkaç saat önce çok sayıda antihipertansif tablet aldığını söylüyor. Hastanın migren ve hipertansiyon nedeniyle propranolol kullandığı öğreniliyor.

Demografi: 52 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 75/40 mmHg | Nabız: 38/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,51

Fizik Muayene

- Hasta somnolandır
- Cilt soğuk ve nemlidir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Beta adrenerjik blokajla ilişkili metabolik etkiyi destekler. | Sonuç yorumu: Beta adrenerjik blokajla ilişkili metabolik etkiyi destekler. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Beta adrenerjik blokajla ilişkili metabolik etkiyi destekler. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / 52 mg/dL / 70-140 mg/dL / Beta adrenerjik blokajla ilişkili metabolik etkiyi destekler.

Tetkik 2: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sinüs bradikardisi izlendi. | Klinik anlam: Kardiyak hız baskılanmasını gösterir. | Sonuç yorumu: Kardiyak hız baskılanmasını gösterir. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Sinüs bradikardisi izlendi. | Yorum: Kardiyak hız baskılanmasını gösterir. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Sinüs bradikardisi izlendi. // Kardiyak hız baskılanmasını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-014 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Sinüs bradikardisi izlendi. | Klinik anlam: Kardiyak hız baskılanmasını gösterir. | URL:

https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/014_014-sinus-bradikardisi-ekg.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/014_014-sinus-bradikardisi-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Sinüs bradikardisi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada glukagonun yararlı olmasını açıklayan temel mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beta-1 adrenerjik reseptörleri doğrudan agonize etmesi
- B) Sodyum kanallarını bloke ederek QRS süresini kısaltması
- C) Muskarinik reseptörleri antagonize ederek vagal tonusu azaltması
- D) Kalsiyum kanallarını inhibe ederek miyokard oksijen tüketimini azaltması
- E) Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi siklik AMP'yi artırması

Doğru Cevap: Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi siklik AMP'yi artırması

A) Beta-1 adrenerjik reseptörleri doğrudan agonize etmesi: Beta-1 adrenerjik reseptörleri doğrudan agonize etmek glukagonun mekanizması değildir; reseptörler ilaç tarafından bloke edildiği için bu yol etkisiz kalabilir. Bu olguda “Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.” ve “Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi siklik AMP'yi artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Sodyum kanallarını bloke ederek QRS süresini kısaltması: Sodyum kanalı blokajı QRS genişlemesiyle ilişkili toksisitelere önemlidir; burada temel sorun sinüs bradikardisi ve beta reseptör blokajıdır. Bu olguda “Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.” ve “Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi siklik AMP'yi artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Muskarinik reseptörleri antagonize ederek vagal tonusu azaltması: Muskarinik reseptör antagonizması atropinin etkisidir ve beta bloker toksisitesindeki miyokard kontraktilite baskılanmasını yeterince düzeltmez. Bu olguda “Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.” ve “Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi sıklık AMP’yi artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Kalsiyum kanallarını inhibe ederek miyokard oksijen tüketimini azaltması: Kalsiyum kanallarını inhibe etmek bradikardi ve hipotansiyonu artırabilir; bu toksisitede tedavi edici bir mekanizma değildir. Bu olguda “Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.” ve “Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi sıklık AMP’yi artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi sıklık AMP’yi artırması: Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktivasyonu ve sıklık AMP artışı glukagonun bu Vakadaki antidotal etkisini açıklar. Vakadaki “Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.” ve “Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bradikardi ve hipotansiyon olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.” ve “Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.” birlikte okunduğunda Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi sıklık AMP’yi artırması seçeneği öne çıkar; “Hipoglisemi lipofilik nonselektif beta blokajla uyumlu ek bir bulgudur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Propranolol alımı sonrası bradikardi, hipotansiyon ve hipoglisemi beta bloker toksisitesini düşündürür. Glukagon, beta adrenerjik reseptörleri kullanmadan kendi reseptörü üzerinden adenilat siklazı aktive eder ve miyokardda sıklık AMP artışıyla inotropi ve kronotropiyi destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.”, “Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.” ve “Hipoglisemi lipofilik nonselektif beta blokajla uyumlu ek bir bulgudur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Beta reseptörlerden bağımsız olarak adenilat siklazı aktive edip hücre içi sıklık AMP’yi artırması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastanın propranolol kullandığı ve çok sayıda antihipertansif tablet aldığı öğrenilmiştir.

Kanıt 2: Belirgin bradikardi ve hipotansiyon kardiyak beta adrenerjik blokajı düşündürür.

Kanıt 3: Hipoglisemi lipofilik nonselektif beta blokajla uyumlu ek bir bulgudur.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Beta bloker zehirlenmesinde glukagon beta reseptöre ihtiyaç duymadan sıklık AMP’yi artırır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 27: v165-new-027-yuzde-sislik-ve-proteinuri

Başlık: Yüzde şişlik ve proteinüri

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri | Nefroloji | Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloyu morfolojik veya histopatolojik paternle ilişkilendirme.

Learning Target: Çocukluk çağı nefrotik sendromunda minimal değişiklik hastalığının elektron mikroskopik bulgusunu seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, göz kapaklarında şişlik ve bacaklarda ödem nedeniyle getiriliyor. Yaklaşık bir haftadır sabahları belirginleşen periorbital şişlik olduğu, idrar renginde koyulaşma veya ağrılı idrar yapma olmadığı öğreniliyor. Yakın zamanda hafif üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiştir.

Demografi: 5 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk nefroloji polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 92/58 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.6°C | Şok indeksi: 1,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Periorbital ödem ve pretibial gode bırakan ödem mevcuttur.
- Akciğer oskültasyonunda belirgin patolojik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar protein/kreatinin oranı

Etiket: İdrar protein/kreatinin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Klinik anlam: Ağır protein kaybını gösterir. | Sonuç yorumu: Ağır protein kaybını gösterir. | Sonuç başlığı: İdrar protein/kreatinin oranı | Sonuç özeti: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Yorum: Ağır protein kaybını gösterir. | Satırlar: İdrar protein/kreatinin oranı / 5.8 mg/mg / <0.2 mg/mg / Ağır protein kaybını gösterir.

Tetkik 2: Serum albümin

Etiket: Serum albümin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Ödem mekanizmasını destekler. | Sonuç yorumu: Ödem mekanizmasını destekler. | Sonuç başlığı: Serum albümin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Ödem mekanizmasını destekler. | Satırlar: Serum albümin / 2.1 g/dL / 3.5-5.0 g/dL / Ödem mekanizmasını destekler.

Tetkik 3: Kompleman C3

Etiket: Kompleman C3 | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal sınırlarda saptandı. | Klinik anlam: Kompleman tüketimi ön planda değildir. | Sonuç yorumu: Kompleman tüketimi ön planda değildir. | Sonuç başlığı: Kompleman C3 | Sonuç özeti: Normal sınırlarda saptandı. | Yorum: Kompleman tüketimi ön planda değildir. | Satırlar: Kompleman C3 / 98 mg/dL / 80-160 mg/dL / Kompleman tüketimi ön planda değildir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-255 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Periorbital ödem ve pretibial gode bırakan ödem mevcuttur | Klinik anlam: Podosit ayakta çıkıntılarında yaygın silinme | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/255_pediatic_leg_rash_clinical_illustration.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/255_pediatic_leg_rash_clinical_illustration.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Periorbital ödem ve pretibial gode bırakan ödem mevcuttur | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta beklenen temel elektron mikroskopik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Subepitelyal immün kompleks birikimleri
- B) Glomerüler bazal membranda çift kontur görünümü
- C) Mezangial immünoglobulin A birikimi
- D) Podosit ayakta çıkıntılarında yaygın silinme
- E) Kresent oluşumu ve fibrinoid nekroz

Doğru Cevap: Podosit ayakta çıkıntılarında yaygın silinme

A) Subepitelyal immün kompleks birikimleri: Subepitelyal immün kompleks birikimleri membranöz nefropatiyi düşündürür; küçük çocukta normal komplemanlı tipik nefrotik tabloyu en iyi açıklamaz. Bu olguda “Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Glomerüller bazal membranda çift kontur görünümü: Glomerüller bazal membranda çift kontur görünümü membranoproliferatif paternle ilişkilidir ve bu Vakadaki klasik çocukluk çağı nefrotik tablosuna uymaz. Bu olguda “Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Mezangial immünooglobulin A birikimi: Mezangial immünooglobulin A birikimi genellikle mukozal enfeksiyon sonrası hematüri ile ilişkili IgA nefropatisini düşündürür. Bu olguda “Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme: Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme, çocukta ödem ve seçici proteinüriyle giden minimal değişiklik hastalığının temel elektron mikroskopik bulgusudur. Vakadaki “Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Kresent oluşumu ve fibrinoid nekroz: Kresent oluşumu ve fibrinoid nekroz hızlı ilerleyen glomerülofrit paternini düşündürür; bu olguda nefrotik tablo ve normal kompleman ön plandadır. Bu olguda “Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yüzde şişlik ve proteinüri olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.” birlikte okunduğunda Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme seçeneği öne çıkar; “Kompleman C3 düzeyinin normal olması inflamatuvar kompleman tüketimini geri plana iter.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çocukta ödem, nefrotik düzeyde proteinüri, hipoalbüminemi, normal kompleman ve hipertansiyon/hematüri yokluğu minimal değişiklik hastalığını düşündürür. Bu hastalıkta ışık mikroskobisi çoğu kez normal olabilir; temel elektron mikroskopik bulgu podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinmedir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.”, “Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.” ve “Kompleman C3 düzeyinin normal olması inflamatuvar kompleman tüketimini geri plana iter.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Podosit ayaksı çıkıntılarında yaygın silinme en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Periorbital ve pretibial ödem ağır protein kaybıyla uyumludur.

Kanıt 2: Nefrotik düzeyde proteinüri ve düşük serum albümini gösterilmiştir.

Kanıt 3: Kompleman C3 düzeyinin normal olması inflamatuvar kompleman tüketimini geri plana iter.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Çocukta nefrotik sendromun en sık nedeni minimal değişiklik hastalığıdır; elektron mikroskopunda podosit ayaksı çıkıntıları silinir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 28: v165-new-028-boyun-cerrahisi-sonrasi-ses-degisikligi

Başlık: Boyun cerrahisi sonrası ses değişikliği

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi / Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Muayene bulgusunu anatomik yapı ve sinir-yapı ilişkisiyle eşleştirme.

Learning Target: Tiroidektomi sonrası ses kısıklığında hasarlanan siniri belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ameliyat sonrası belirgin ses kısıklığı ve konuşurken çabuk yorulma nedeniyle değerlendiriliyor. Multinodüler guatr nedeniyle total tiroidektomi yapıldığı, ameliyattan önce ses kısıklığı olmadığı öğreniliyor. Yutma güçlüğü veya ağır köşesinde kayma tariflemiyor.

Demografi: 46 yaşında kadın hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta konuşurken sesi kısık ve nefesli duyulmaktadır.
- Ağız içi muayenede uvula orta hatta izlenir.
- Dil hareketleri simetriktrir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fleksibl laringoskopi

Etiket: Fleksibl laringoskopi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Tek taraflı vokal kord hareketinde belirgin azalma izlendi. | Klinik anlam: Larengeal motor innervasyon etkilenimini gösterir. | Sonuç yorumu: Larengeal motor innervasyon etkilenimini gösterir. | Sonuç başlığı: Fleksibl laringoskopi | Sonuç özeti: Tek taraflı vokal kord hareketinde belirgin azalma izlendi. | Yorum: Larengeal motor innervasyon etkilenimini gösterir. | Satırlar: Fleksibl laringoskopi / Tek taraflı vokal kord hareketinde belirgin azalma izlendi. // Larengeal motor innervasyon etkilenimini gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanması en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus hypoglossus
- B) Nervus glossopharyngeus
- C) Nervus laryngeus recurrens
- D) Ramus marginalis mandibulae nervi facialis
- E) Nervus accessorius

Doğru Cevap: Nervus laryngeus recurrens

A) Nervus hypoglossus: Nervus hypoglossus dil kaslarını innerve eder; dil deviasyonu beklenmediği için vokal kord hareket kusurunu açıklamaz. Bu olguda “Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.” ve “Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nervus glossopharyngeus: Nervus glossopharyngeus tat, yutma ve farengeal duyuda önemlidir; tek taraflı vokal kord motor kaybının ana siniri değildir. Bu olguda “Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.” ve “Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.” ipuçları tanısar karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus laryngeus recurrens: Nervus laryngeus recurrens tiroid cerrahisi sırasında risk altındadır ve intrinsek larenks kaslarının çoğunu innerve ederek vokal kord hareketini sağlar. Vakadaki “Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.” ve “Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

D) Ramus marginalis mandibulae nervi facialis: Ramus marginalis mandibulae nervi facialis alt dudak kaslarını etkiler; ağız köşesi asimetrisi olmadan vokal kord paralizisini açıklamaz. Bu olguda “Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.” ve “Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.” ipuçları tanısar karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus accessorius: Nervus accessorius trapezius ve sternokleidomastoid kas fonksiyonlarıyla ilişkilidir; ses kısıklığı ve vokal kord hareket azalmasının temel nedeni değildir. Bu olguda “Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.” ve “Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.” ipuçları tanısar karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Boyun cerrahisi sonrası ses değişikliği olgusunda klinik karar tanısar karar üzerine kuruludur. “Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.” ve “Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.” birlikte okunduğunda Nervus laryngeus recurrens seçeneği öne çıkar; “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareketinde azalma izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tiroidektomi sonrası yeni gelişen ses kısıklığı ve tek taraflı vokal kord hareket azalması larenksin intrinsek kas motor innervasyonunda hasarı düşündürür. Bu klinik bağlamda en olası yapı nervus laryngeus recurrens'tir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.”, “Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.” ve “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareketinde azalma izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus laryngeus recurrens en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Ses kısıklığı ameliyat sonrası yeni başlamıştır.

Kanıt 2: Cerrahi girişim tiroid bezi çevresinde yapılmıştır.

Kanıt 3: Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareketinde azalma izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Tiroidektomi sonrası vokal kord paralizisi ve ses kısıklığı en çok nervus laryngeus recurrens hasarıyla ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 29: v165-new-029-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon

Başlık: Göğüs ağrısı ve hipotansiyon

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Kardiyoloji / Acil Tıp | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Sağ ventrikül tutulumlu inferior miyokard enfarktüsünde nitrat kullanımının riskini ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, 45 dakikadır süren baskı tarzında göğüs ağrısı nedeniyle acile başvuruyor. Ağrının retrosternal başladığı ve sol kola yayıldığı öğreniliyor. Hipertansiyon ve sigara öyküsü vardır. Son saatlerde fosfodiesteraz-5 inhibitörü kullanımı tariflemiyor.

Demografi: 63 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/50 mmHg | Nabız: 54/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %95 | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,66

Fizik Muayene

- Hasta terli ve huzursuzdur.
- Juguler venöz dolgunluk izlenir.
- Akciğer oskültasyonunda ral duyulmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; sağ prekordiyal V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: Inferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu düşündürür. | Sonuç yorumu: Inferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu düşündürür. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; sağ prekordiyal V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Yorum: Inferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu düşündürür. | Satırlar: Elektrokardiyografi / DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; sağ prekordiyal V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. // Inferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-015 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; sağ prekordiyal V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: Inferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu düşündürür. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/015_015-inferior-stemi-sag-ventrikul-tutulumu-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/015_015-inferior-stemi-sag-ventrikul-tutulumu-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; sağ prekordiyal V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada başlangıç yönetiminde kaçınılması gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nitrogliserin
B) Aspirin
C) Heparin
D) Klopidoğrel
E) Atropin

Doğru Cevap: Nitrogliserin

A) Nitrogliserin: Nitrogliserin venöz dönüşü azaltır ve sağ ventrikül tutulumlu hipotansif hastada preload düşüşüyle dolaşımı daha da bozabilir. Vakadaki “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Aspirin: Aspirin akut koroner sendromda trombosit aktivasyonunu azaltan temel tedavidir ve bu nedenle kaçınılması gereken seçenek değildir. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nitrogliserin seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Heparin: Heparin trombotik sürecin ilerlemesini sınırlamak için uygun antikoagülan tedavi olabilir; hipotansif sağ ventrikül tutulumunda spesifik olarak yasaklanan ilaç değildir. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi

önceliği açısından Nitrogliserin seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Klopidoğrel: Klopidoğrel çift antiplatelet tedavinin parçası olabilir ve bu Vakadaki temel hemodinamik tehlike mekanizmasını oluşturmaz. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nitrogliserin seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Atropin: Atropin semptomatik bradikardi varlığında yararlı olabilir; nitrat gibi preloadu azaltarak hipotansiyonu kötüleştirmez. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nitrogliserin seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Göğüs ağrısı ve hipotansiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.” birlikte okunduğunda Nitrogliserin seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon ve juguler venöz dolgunluk akciğer ralinin olmamasıyla birlikte preload bağımlı tabloyu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Inferior ST elevasyonu, V4R’de ST elevasyonu, hipotansiyon, juguler venöz dolgunluk ve akciğerlerin temiz olması sağ ventrikül tutulumunu düşündürür. Bu hastalarda kardiyak debi preload bağımlıdır; nitrogliserin venodilatasyonla preloadu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.”, “Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve juguler venöz dolgunluk akciğer ralinin olmamasıyla birlikte preload bağımlı tabloyu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nitrogliserin en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.

Kanıt 2: Sağ prekordiyal derivasyonda ST elevasyonu sağ kalp tutulumunu düşündürür.

Kanıt 3: Hipotansiyon ve juguler venöz dolgunluk akciğer ralinin olmamasıyla birlikte preload bağımlı tabloyu destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Sağ ventrikül tutulumlu inferior enfarktüste nitrat preloadu azaltarak ciddi hipotansiyon yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 30: v165-new-030-hipotansiyon-ve-elektrolit-bozuklugu

Başlık: Hipotansiyon ve elektrolit bozukluğu

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Endokrinoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Primer adrenal yetmezlik krizinde klinik ve laboratuvar bulgularla acil tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kusma, karın ağrısı ve bayılacak gibi olma nedeniyle acile getiriliyor. Son birkaç gündür ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği, bu süreçte halsizlik ve iştahsızlığının arttığı öğreniliyor. Son aylarda kilo kaybı ve ciltte koyulaşma fark ettiğini belirtiyor.

Demografi: 39 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 78/46 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 38.2°C | Şok indeksi: 1,64 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta bitkin ve dehidrate görünümündedir.
- Deri kıvrımlarında ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Mineralokortikoid ve kortizol eksikliğini destekleyebilir. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid ve kortizol eksikliğini destekleyebilir. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Mineralokortikoid ve kortizol eksikliğini destekleyebilir. | Satırlar: Serum sodyum / 124 mmol/L / 135-145 mmol/L / Mineralokortikoid ve kortizol eksikliğini destekleyebilir.

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aldosteron eksikliğiyle uyumludur. | Sonuç yorumu: Aldosteron eksikliğiyle uyumludur. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Aldosteron eksikliğiyle uyumludur. | Satırlar: Serum potasyum / 5.9 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Aldosteron eksikliğiyle uyumludur.

Tetkik 3: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kortizol eksikliğinin metabolik etkisini destekler. | Sonuç yorumu: Kortizol eksikliğinin metabolik etkisini destekler. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kortizol eksikliğinin metabolik etkisini destekler. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / 58 mg/dL / 70-140 mg/dL / Kortizol eksikliğinin metabolik etkisini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-256 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Deri kıvrımlarında ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon izlenir | Klinik anlam: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/256_detailed_skin_and_mucosal_pigmentation_analysis.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/256_detailed_skin_and_mucosal_pigmentation_analysis.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Deri kıvrımlarında ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon izlenir | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk acil tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) Oral tuz tabletleri ve ayaktan takip
- B) Hipertonik salin infüzyonu ve sıvı kısıtlaması
- C) Yüksek doz levotiroksin başlanması
- D) Potasyum tutucu diüretik verilmesi
- E) İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı

Doğru Cevap: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı

A) Oral tuz tabletleri ve ayaktan takip: Vakadaki Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir ve Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışı düşündürür. Bu olguda “Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.” ve “Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışı düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Hipertonik salin infüzyonu ve sıvı kısıtlaması: Hipertonik salin ve sıvı kısıtlaması uygunsuz antidiüretik hormon fazlalığı gibi durumlarda düşünülebilir; bu olguda hacim kaybı ve hormon eksikliği ön plandadır. Bu olguda “Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.” ve “Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışı düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Yüksek doz levotiroksin başlanması: Yüksek doz levotiroksin bu elektrolit ve şok tablosunu düzeltmez; adrenal yetmezlik düzeltilmeden tiroid hormonu verilmesi tabloyu kötüleştirebilir. Bu olguda “Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.” ve “Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin

artışını düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Potasyum tutucu diüretik verilmesi: Vakadaki Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir ve Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışını düşündürür. Bu olguda “Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.” ve “Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışını düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı seçeneğini daha güçlü kılar.

E) İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı hipotansiyon, hipoglisemi ve elektrolit bozukluklarıyla seyreden bu acil tabloda ilk tedavidir. Vakadaki “Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.” ve “Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışını düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hipotansiyon ve elektrolit bozukluğu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.” ve “Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışını düşündürür.” birlikte okunduğunda İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı seçeneği öne çıkar; “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte hormonal eksiklik tablosunu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipotansiyon, hiperpigmentasyon, hiponatremi, hiperkalemi, hipoglisemi ve enfeksiyonla tetiklenme primer adrenal yetmezlik krizini düşündürür. İlk acil tedavi dolaşımı düzeltmek için izotonik sıvı ve eksik glukokortikoid etkisini hızla yerine koymak için intravenöz hidrokortizondur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.”, “Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışını düşündürür.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte hormonal eksiklik tablosunu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı replasmanı en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Ateşli enfeksiyon sonrası kusma, karın ağrısı ve ciddi hipotansiyon gelişmiştir.

Kanıt 2: Deri ve ağız mukozasında hiperpigmentasyon kronik kortikotropin artışını düşündürür.

Kanıt 3: Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte hormonal eksiklik tablosunu destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Adrenal krizde tanısıl doğrulama beklenmeden intravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 31: v166-new-031-gebelikte-kanama-sonrasi-degerlendirme

Başlık: Gebelikte kanama sonrası değerlendirme

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Rh-negatif duyarlı olmayan gebede kanama sonrası uygun anti-D profilaksisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, hafif vajinal kanama ve karın alt bölgesinde kramp tarzı ağrı nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki saat önce merdivende kayarak dizlerinin üzerine düştüğünü, ardından az miktarda vajinal lekelenme fark ettiğini belirtiyor. İlk gebeliğidir. Önceki gebelik kaybı, transfüzyon veya invaziv prenatal işlem öyküsü yoktur.

Demografi: 26 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,79

Fizik Muayene

- Genel durumu iyidir, bilinci açıktır.
- Uterus hassasiyeti belirgin değildir; aktif yoğun kanama izlenmez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan grubu

Etiket: Kan grubu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Anne Rh-negatif, baba Rh-pozitif olarak bildirildi. | Klinik anlam: Fetomaternal kanama sonrası alloimmünizasyon riski açısından önemlidir. | Sonuç yorumu: Fetomaternal kanama sonrası alloimmünizasyon riski açısından önemlidir. | Sonuç başlığı: Kan grubu | Sonuç özeti: Anne Rh-negatif, baba Rh-pozitif olarak bildirildi. | Yorum: Fetomaternal kanama sonrası alloimmünizasyon riski açısından önemlidir. | Satırlar: Kan grubu / Anne Rh-negatif, baba Rh-pozitif olarak bildirildi. / Fetomaternal kanama sonrası alloimmünizasyon riski açısından önemlidir.

Tetkik 2: İndirekt Coombs testi

Etiket: İndirekt Coombs testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Negatif saptandı. | Klinik anlam: Annenin henüz duyarlılaşmadığını gösterir. | Sonuç yorumu: Annenin henüz duyarlılaşmadığını gösterir. | Sonuç başlığı: İndirekt Coombs testi | Sonuç özeti: Negatif saptandı. | Yorum: Annenin henüz duyarlılaşmadığını gösterir. | Satırlar: İndirekt Coombs testi / Negatif saptandı. // Annenin henüz duyarlılaşmadığını gösterir.

Tetkik 3: Obstetrik ultrasonografi

Etiket: Obstetrik ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Fetal kalp aktivitesi mevcut, plasentada belirgin ayrılma bulgusu izlenmedi. | Klinik anlam: Acil fetal değerlendirme açısından rahatlatıcıdır. | Sonuç yorumu: Acil fetal değerlendirme açısından rahatlatıcıdır. | Sonuç başlığı: Obstetrik ultrasonografi | Sonuç özeti: Fetal kalp aktivitesi mevcut, plasentada belirgin ayrılma bulgusu izlenmedi. | Yorum: Acil fetal değerlendirme açısından rahatlatıcıdır. | Satırlar: Obstetrik ultrasonografi / Fetal kalp aktivitesi mevcut, plasentada belirgin ayrılma bulgusu izlenmedi. // Acil fetal değerlendirme açısından rahatlatıcıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-016 | Başlık: Obstetrik ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Fetal kalp aktivitesi mevcut, plasentada belirgin ayrılma bulgusu izlenmedi. | Klinik anlam: Acil fetal değerlendirme açısından rahatlatıcıdır. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/016_016-fetal-kalp-aktivitesi-obstetrik-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/016_016-fetal-kalp-aktivitesi-obstetrik-ultrasonografi.webp | Alt text: Obstetrik ultrasonografi - Fetal kalp aktivitesi mevcut, plasentada belirgin ayrılma bulgusu izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada alloimmünizasyonu önlemek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anti-D immünoglobulin uygulanması
- B) Anneye eritrosit transfüzyonu yapılması
- C) Kanama sonrası fetal Rh durumunu bekleyerek anti-D profilaksisini ertelemek
- D) Gebelik boyunca kortikosteroid profilaksisi verilmesi
- E) İndirekt Coombs sonucuna göre profilaksi kararını ertelemek

Doğru Cevap: Anti-D immünoglobulin uygulanması

A) Anti-D immünoglobulin uygulanması: Anti-D immünoglobulin, duyarlı olmayan Rh-negatif gebede olası Rh-pozitif fetal eritrositlere karşı immünizasyonu önlediği için en uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.” ve “İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.” ipuçları birlikte

değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Anneye eritrosit transfüzyonu yapılması: Anneye eritrosit transfüzyonu hemodinamik instabilite veya ciddi kan kaybında düşünülür; bu olguda amaç alloimmünizasyon profilaksisidir. Bu olguda “Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.” ve “İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anti-D immünoglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Kanama sonrası fetal Rh durumunu bekleyerek anti-D profilaksisini ertelemek: Seri ultrasonografi fetal izlem sağlayabilir ancak maternal Rh alloimmünizasyon riskini önlemez. Bu olguda “Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.” ve “İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anti-D immünoglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Gebelik boyunca kortikosteroid profilaksisi verilmesi: Kortikosteroid profilaksisi fetal akciğer maturasyonu gibi farklı endikasyonlarda kullanılır; Rh duyarlanmasını engellemez. Bu olguda “Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.” ve “İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anti-D immünoglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) İndirekt Coombs sonucuna göre profilaksi kararını ertelemek: Vakadaki Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir ve İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir. Bu olguda “Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.” ve “İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Anti-D immünoglobulin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte kanama sonrası değerlendirme olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.” ve “İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.” birlikte okunduğunda Anti-D immünoglobulin uygulanması seçeneği öne çıkar; “Travma sonrası vajinal lekelenme fetomaternal kanama riskini artırır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Rh-negatif ve indirekt Coombs testi negatif olan gebe, travma ve vajinal kanama sonrası fetomaternal kanama riski taşır. Anne henüz duyarlılaşmadan anti-D immünoglobulin verilmesi, fetal Rh-pozitif eritrositlere karşı maternal immün yanıt gelişmesini önler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.”, “İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.” ve “Travma sonrası vajinal lekelenme fetomaternal kanama riskini artırır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Anti-D immünoglobulin uygulanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Anne Rh-negatif ve baba Rh-pozitif olarak bildirilmiştir.

Kanıt 2: İndirekt Coombs testinin negatif olması annenin duyarlılaşmadığını gösterir.

Kanıt 3: Travma sonrası vajinal lekelenme fetomaternal kanama riskini artırır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağına yerine geçmez.

Exam Pearl: Rh-negatif duyarlı olmayan gebede kanama, travma, invaziv işlem veya doğum sonrası anti-D profilaksisi alloimmünizasyonu önler.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 32: v166-new-032-ishal-sonrasi-bobrek-yetmezligi

Başlık: İshal sonrası böbrek yetmezliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Nefroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Kanlı ishal sonrası gelişen hemolitik üremik sendromda temel patogenezi ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, az idrar yapma, solukluk ve halsizlik nedeniyle acile getiriliyor. Bir hafta önce kanlı ishal ve karın ağrısı geçirdiği, bu dönemde antibiyotik kullanmadığı öğreniliyor. Son iki gündür idrar miktarının belirgin azaldığı ve halsizliğinin arttığı belirtiliyor.

Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 125/78 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.2°C | Şok indeksi: 0,90

Fizik Muayene

- Çocuk soluk ve halsiz görünümündedir.
- Periorbital hafif ödem vardır.
- Peteşi tarzı döküntüler izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Anemi ve trombositopeni saptandı. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik süreç açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Mikroanjyopatik süreç açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Anemi ve trombositopeni saptandı. | Yorum: Mikroanjyopatik süreç açısından anlamlıdır. | Satırlar: Tam kan sayımı / Hb 8.1; trombosit 58.000 g/dL / mm³ / Hb 11.5-13.5 g/dL; trombosit 150.000-450.000 /mm³ / Mikroanjyopatik süreç açısından anlamlıdır.

Tetkik 2: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Şistositler görüldü. | Klinik anlam: Damar içi mekanik eritrosit hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Damar içi mekanik eritrosit hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Şistositler görüldü. | Yorum: Damar içi mekanik eritrosit hasarını destekler. | Satırlar: Periferik yayma / Şistositler görüldü. // Damar içi mekanik eritrosit hasarını destekler.

Tetkik 3: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut böbrek hasarını gösterir. | Sonuç yorumu: Akut böbrek hasarını gösterir. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut böbrek hasarını gösterir. | Satırlar: Serum kreatinin / 1.8 mg/dL / 0.2-0.7 mg/dL / Akut böbrek hasarını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-017 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Şistositler görüldü. | Klinik anlam: Damar içi mekanik eritrosit hasarını destekler. | URL:

https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/017_017-yaygin-sistositler-periferik-yayma.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/017_017-yaygin-sistositler-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Şistositler görüldü. | Asset durumu:

vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-257 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Peteşi tarzı döküntüler izlenir | Klinik anlam: Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik

mikroanjyopati oluşturmaması | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/257_legs_with_petechiae_during_medical_exam.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/257_legs_with_petechiae_during_medical_exam.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Peteşi tarzı döküntüler izlenir | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel patogenetik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Glomerüler bazal membrana karşı IgG antikor gelişmesi
- B) Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjyopati oluşturmaması

- C) İmmün komplekslerin mezangiumda birikerek nefrit oluşturmaları
D) C1 esteraz inhibitör eksikliğine bağlı damar geçirgenliği artışı
E) Renal tübüllerde sistin kristallerinin birikmesi

Doğru Cevap: Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları

A) Glomerüler bazal membrana karşı IgG antikor gelişmesi: Glomerüler bazal membrana karşı IgG antikor gelişmesi Goodpasture sendromu mekanizmasıdır ve kanlı ishal sonrası trombotik mikroanjiyopatiji açıklamaz. Bu olguda “Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.” ve “Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları: Shiga toksininin endotel hasarı oluşturmaları, bu Vakadaki şistositli hemoliz, trombositopeni ve akut böbrek hasarının temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.” ve “Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

C) İmmün komplekslerin mezangiumda birikerek nefrit oluşturmaları: İmmün kompleks birikimi glomerülofritlerde önemlidir ancak bu hastadaki trombositopeni ve şistositlerle giden mikroanjiyopatik tabloyu en iyi açıklamaz. Bu olguda “Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.” ve “Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.

D) C1 esteraz inhibitör eksikliğine bağlı damar geçirgenliği artışı: C1 esteraz inhibitör eksikliği hereditör anjiyoödemle ilişkilidir; böbrek yetmezliği ve mikroanjiyopatik hemoliz beklenen temel bulgular değildir. Bu olguda “Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.” ve “Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Renal tübüllerde sistin kristallerinin birikmesi: Renal tübüllerde sistin kristali birikimi sistinozisle ilişkilidir ve kanlı ishal sonrası gelişen akut tabloyu açıklamaz. Bu olguda “Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.” ve “Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekeçe / Kanıt / Core

Klinik gerekeçe: İshal sonrası böbrek yetmezliği olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.” ve “Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” birlikte okunduğunda Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları seçeneği öne çıkar; “Az idrar yapma ve kreatinin yüksekliği akut böbrek hasarını destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kanlı ishalden sonra gelişen akut böbrek hasarı, trombositopeni ve şistositli hemolitik anemi tipik hemolitik üremik sendrom tablosudur. Shiga toksini endotel hasarı yaparak küçük damarlarda trombüs oluşumuna ve mikroanjiyopatik hemolize yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.”, “Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ve “Az idrar yapma ve kreatinin yüksekliği akut böbrek hasarını destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Shiga toksininin endoteli zedeleyerek trombotik mikroanjiyopati oluşturmaları en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Tablo kanlı ishalden yaklaşık bir hafta sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.

Kanıt 3: Az idrar yapma ve kreatinin yüksekliği akut böbrek hasarını destekler.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Çocukta kanlı ishal sonrası anemi, trombositopeni ve böbrek yetmezliği varsa Shiga toksin ilişkili hemolitik üremik sendrom düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 33: v166-new-033-hiperglisemik-acil-tablo

Başlık: Hiperglisemik acil tablo

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Endokrinoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Diyabetik ketoasidozda ilk tedavi basamağını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bulantı, kusma ve derin hızlı solunum nedeniyle acile getiriliyor. Son iki gündür ateşli üst solunum yolu yakınmaları olduğunu ve insülin dozlarını aksattığını belirtiyor. Susama, sık idrara çıkma ve giderek artan halsizlik tarifliyor.

Demografi: 22 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 92/58 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 37.9°C | Şok indeksi: 1,35 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta dehidrate ve halsiz görünümündedir.
- Mukozaları kurudur
- Solunumu derin ve hızlıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma glukozu

Etiket: Plazma glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hiperglisemik krizi destekler. | Sonuç yorumu: Hiperglisemik krizi destekler. | Sonuç başlığı: Plazma glukozu | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hiperglisemik krizi destekler. | Satırlar: Plazma glukozu / 486 mg/dL / 70-140 mg/dL / Hiperglisemik krizi destekler.

Tetkik 2: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Ketoasidozla uyumludur. | Sonuç yorumu: Ketoasidozla uyumludur. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Ketoasidozla uyumludur. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.12; HCO₃ 8; mmol/L / pH 7.35-7.45; HCO₃ 22-26 mmol/L / Ketoasidozla uyumludur.

Tetkik 3: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek-normal sınıra yakın saptandı. | Klinik anlam: Tedavi sırasında yakından izlenmelidir. | Sonuç yorumu: Tedavi sırasında yakından izlenmelidir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek-normal sınıra yakın saptandı. | Yorum: Tedavi sırasında yakından izlenmelidir. | Satırlar: Serum potasyum / 5.2 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Tedavi sırasında yakından izlenmelidir.

Tetkik 4: İdrar ketonu

Etiket: İdrar ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Ketozisi destekler. | Sonuç yorumu: Ketozisi destekler. | Sonuç başlığı: İdrar ketonu | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Ketozisi destekler. | Satırlar: İdrar ketonu / Pozitif saptandı. // Ketozisi destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-258 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Solunumu derin ve hızlıdır | Klinik anlam: İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/258_distressed_patient_in_emergency_room.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/258_distressed_patient_in_emergency_room.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Solunumu derin ve hızlıdır | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk tedavi basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması
- B) İntravenöz bikarbonat tedavisi başlanması
- C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanması
- D) Potasyum replasmanının hemen başlanması
- E) Oral antidiyabetik tedaviye geçilmesi

Doğru Cevap: İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması

A) İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması: İntravenöz izotonik sıvı tedavisi, dehidratasyon ve hipovolemiyi düzelterek diyabetik ketoasidoz yönetiminin ilk basamağını oluşturur. Vakadaki “İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.” ve “pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) İntravenöz bikarbonat tedavisi başlanması: Bikarbonat tedavisi yalnızca çok ağır asidoz gibi seçilmiş durumlarda düşünülür; bu olguda ilk ve rutin yaklaşım değildir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.” ve “pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanması: Subkutan hızlı etkili insülin ağır ketoasidozda ilk tercih değildir; intravenöz insülin sıvı ve potasyum değerlendirmesi sonrası planlanır. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.” ve “pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Potasyum replasmanının hemen başlanması: Potasyum replasmanı serum potasyumu düşüğe önceliklidir; bu hastada potasyum yüksek-normal düzeydedir ve ilk adım sıvı tedavisidir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.” ve “pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oral antidiyabetik tedaviye geçilmesi: Oral antidiyabetik tedavi tip 1 diyabetli ve ketoasidozdaki hastada acil tedavi seçeneği değildir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.” ve “pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hiperglisemik acil tablo olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.” ve “pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.” birlikte okunduğunda İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon, taşikardi ve kuru mukozalar ciddi sıvı kaybını düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada hiperglisemi, ketonüri, metabolik asidoz, Kussmaul solunumu ve belirgin dehidratasyon diyabetik ketoasidozu gösterir. İlk basamak dolaşım hacmini düzeltmek için intravenöz izotonik sıvı tedavisidir; insülin ve elektrolit yönetimi sıvı resüsitasyonu ve potasyum değerlendirmesiyle birlikte planlanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.”, “pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve kuru mukozalar ciddi sıvı kaybını düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz izotonik sıvı tedavisi başlanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: İnsülin dozlarının aksaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.

Kanıt 2: pH ve bikarbonat değerleri belirgin metabolik asidozu gösterir.

Kanıt 3: Hipotansiyon, taşikardi ve kuru mukozalar ciddi sıvı kaybını düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Diyabetik ketoasidozda ilk yaklaşım izotonik sıvı resüsitasyonudur; insülin tedavisi potasyum durumu gözetilerek başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 34: v166-new-034-gun-icinde-artan-kas-gucsuzlugu

Başlık: Gün içinde artan kas güçsüzlüğü

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Nöroloji / İmmünoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Miyastenia graviste temel otoimmün mekanizmayı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, çift görme, göz kapağı düşüklüğü ve gün sonunda belirginleşen yorgunluk nedeniyle başvuruyor. Şikâyetlerinin birkaç aydır aralıklı olduğunu, özellikle uzun süre konuşunca sesinin zayıfladığını ve merdiven çıkarken çabuk yorulduğunu belirtiyor. Sabah saatlerinde daha iyi olduğunu, dinlenmeye yakınmalarının azaldığını ifade ediyor.

Demografi: 34 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bilateral pitozis mevcuttur ve yukarı bakışın sürdürülmesiyle belirginleşmektedir.
- Proksimal kaslarda hafif güçsüzlük vardır.
- Duyu muayenesi normaldir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tekrarlayan sinir uyarım testi

Etiket: Tekrarlayan sinir uyarım testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Ardışık uyanılarda bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdünde dekrement yanıt izlendi. | Klinik anlam: Nöromüsküler kavşak iletim bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Nöromüsküler kavşak iletim bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Tekrarlayan sinir uyarım testi | Sonuç özeti: Ardışık uyanılarda bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdünde dekrement yanıt izlendi. | Yorum: Nöromüsküler kavşak iletim bozukluğunu destekler. | Satırlar: Tekrarlayan sinir uyarım testi / Ardışık uyanılarda bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdünde dekrement yanıt izlendi. // Nöromüsküler kavşak iletim bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: Asetilkolin reseptör antikoru

Etiket: Asetilkolin reseptör antikoru | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Otoimmün reseptör hedeflenmesini destekler. | Sonuç yorumu: Otoimmün reseptör hedeflenmesini destekler. | Sonuç başlığı: Asetilkolin reseptör antikoru | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Otoimmün reseptör hedeflenmesini destekler. | Satırlar: Asetilkolin reseptör antikoru / Pozitif saptandı. // Otoimmün reseptör hedeflenmesini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağılı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel patofizyolojik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi
- B) Presinaptik voltaj kapılı kalsiyum kanallarına karşı otoantikor gelişmesi
- C) Periferik sinir miyelinine karşı segmental demiyelinizasyon gelişmesi
- D) Dopaminerjik nöronlarda alfa-sinüklein birikimi olması
- E) Üst motor nöronlarda glutamat aracılı dejenerasyon gelişmesi

Doğru Cevap: Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi

A) Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi: Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi, bu Vakadaki dalgalanan pitozis ve dekrement yanıtı en iyi açıklar. Vakadaki “Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.” ve “Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Presinaptik voltaj kapılı kalsiyum kanallarına karşı otoantikor gelişmesi: Presinaptik voltaj kapılı kalsiyum kanallarına karşı otoantikor gelişmesi Lambert-Eaton miyastenik sendromunun mekanizmasıdır ve genellikle güç kullanım ile geçici düzelme beklenir. Bu olguda “Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.” ve “Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Periferik sinir miyelinine karşı segmental demiyelinizasyon gelişmesi: Periferik sinir miyelinine karşı segmental demiyelinizasyon Guillain-Barré sendromu gibi nöropatilerde beklenir; burada duyu kaybı yoktur ve nöromüsküler kavşak bulguları ön plandadır. Bu olguda “Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.” ve “Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Dopaminerjik nöronlarda alfa-sinüklein birikimi olması: Dopaminerjik nöronlarda alfa-sinüklein birikimi Parkinson hastalığıyla ilişkilidir ve dalgalanan oküler kas güçsüzlüğünü açıklamaz. Bu olguda “Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.” ve “Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Üst motor nöronlarda glutamat aracılı dejenerasyon gelişmesi: Üst motor nöron dejenerasyonu spastisite ve patolojik reflekslerle beklenir; bu hastada yorulabilir nöromüsküler iletim bozukluğu vardır. Bu olguda “Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.” ve “Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gün içinde artan kas güçsüzlüğü olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.” ve “Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.” birlikte okunduğunda Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi seçeneği öne çıkar; “Tekrarlayan sinir uyarımında dekrement yanıt saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Dalgalanan oküler ve proksimal kas güçsüzlüğü, dinlenmeyle düzelme, dekrement yanıt ve asetilkolin reseptör antikor pozitifliği miyastenia gravis ile uyumludur. Temel mekanizma postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerinin otoantikorlarla hedeflenmesi ve nöromüsküler iletimin azalmasıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.”, “Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.” ve “Tekrarlayan sinir uyarımında dekrement yanıt saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Postsinaptik nikotinik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kas güçsüzlüğü gün sonunda artmakta ve dinlenmeyle azalmaktadır.

Kanıt 2: Pitozis ve çift görme oküler kas tutulumunu düşündürür.

Kanıt 3: Tekrarlayan sinir uyarımında dekrement yanıt saptanmıştır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Miyastenia graviste sorun postsinaptik asetilkolin reseptöründedir; Lambert-Eaton sendromunda ise presinaptik kalsiyum kanalı hedeflenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 35: v166-new-035-ates-ve-inspiratuvar-solunum-sikintisi

Başlık: Ateş ve inspiratuvar solunum sıkıntısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Acil Tıp | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Epiglottit şüphesinde güvenli ilk yaklaşımı belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş, yutamama ve solunum sıkıntısı nedeniyle acile getiriliyor. Yakınmaları aynı gün içinde hızla başlamıştır. Ailesi çocuğun tükürüğünü yutamadığını, sesinin boğuklaştığını ve yatınca nefesinin daha kötüleştiğini belirtmektedir. Aşılarının eksik olduğu öğreniliyor.

Demografi: 3 yaşında erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 152/dk | Solunum: 34/dk | SpO₂: %92 | Ateş: 39.2°C | Şok indeksi: 1,52 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk ajite, toksik görünümlü ve öne eğilerek oturur pozisyonundadır.
- Ağızdan salya akışı vardır.
- Inspiratuvar stridor duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağılı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk ve en güvenli yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil serviste dil basacağı ile orofarenks muayenesi yapılması

- B) Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması
C) Ayaktan oral antibiyotik başlanması
D) Nebülize bronkodilatör yanıtına göre ayaktan izlem planlamak
E) Boğaz kültürü alınması için çocuğun yatırılarak izlem planlanması

Doğru Cevap: Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması

A) Acil serviste dil basacağı ile orofarens muayenesi yapılması: Dil basacağı ile orofarens muayenesi epiglottit şüphesinde laringospazm ve tam hava yolu obstrüksiyonu riskini artırabileceği için güvenli değildir. Bu olguda “Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.” ve “Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması: Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması, stridor ve salya akışı olan toksik çocukta ilk ve en güvenli yaklaşımdır. Vakadaki “Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.” ve “Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Ayaktan oral antibiyotik başlanması: Ayaktan oral antibiyotik üst hava yolu obstrüksiyonu riski taşıyan bu hastada yetersiz ve güvensizdir. Bu olguda “Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.” ve “Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nebülize bronkodilatör yanıtına göre ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir ve Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür. Bu olguda “Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.” ve “Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Boğaz kültürü alınması için çocuğun yatırılarak izlem planlanması: Vakadaki Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir ve Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür. Bu olguda “Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.” ve “Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve inspiratuvar solunum sıkıntısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.” ve “Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” birlikte okunduğunda Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması seçeneği öne çıkar; “Toksik görünüm ve yüksek ateş ciddi bakteriyel üst hava yolu enfeksiyonu olasılığını artırır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yüksek ateş, toksik görünüm, salya akışı, tripod pozisyonu ve inspiratuvar stridor epiglottit açısından yüksek riskli hava yolu tablosudur. Bu durumda ajitasyon veya agresif ağız muayenesi hava yolu obstrüksiyonunu artırabileceğinden ilk güvenli yaklaşım kontrollü koşullarda hava yolunu güvence altına almaktır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.”, “Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” ve “Toksik görünüm ve yüksek ateş ciddi bakteriyel üst hava yolu enfeksiyonu olasılığını artırır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kontrollü koşullarda hava yolunun güvence altına alınması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk tükürüğünü yutamamakta ve ağızdan salya akışı göstermektedir.

Kanıt 2: Öne eğilerek oturma ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.

Kanıt 3: Toksik görünüm ve yüksek ateş ciddi bakteriyel üst hava yolu enfeksiyonu olasılığını artırır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Epiglottit şüphesinde dil basacağıyla boğaz muayenesi yapılmaz; önce kontrollü ortamda hava yolu güvenceye alınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 36: v166-new-036-ates-ve-yeni-ufurum

Başlık: Ateş ve yeni üfürüm

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Enfeksiyon Hastalıkları / Kardiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik bağlam ve mikrobiyolojik ipuçlarıyla olası etkeni belirleme.

Learning Target: Damar içi madde kullanımı sonrası sağ kalp enfektif endokarditinde en olası etkeni seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, titreme ve nefes alırken artan göğüs ağrısı nedeniyle başvuruyor. Son iki haftadır aralıklı ateş ve gece terlemesi olduğunu, son günlerde öksürük ve batıcı göğüs ağrısı geliştiğini belirtiyor. Damar içi madde kullanımı öyküsü vardır.

Demografi: 32 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 105/66 mmHg | Nabız: 116/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 38.8°C | Şok indeksi: 1,10 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta febril ve halsiz görünümündedir.
- Triküspit odakta sistolik üfürüm duyulur.
- Akciğerlerde bilateral dağınık raller mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan kültürü

Etiket: Kan Kültürü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Gram-pozitif kok kümeleri üredi. | Klinik anlam: Etken ayrımı açısından morfolojik ipucu sağlar. | Sonuç yorumu: Etken ayrımı açısından morfolojik ipucu sağlar. | Sonuç başlığı: Kan kültürü | Sonuç özeti: Gram-pozitif kok kümeleri üredi. | Yorum: Etken ayrımı açısından morfolojik ipucu sağlar. | Satırlar: Kan kültürü / Gram-pozitif kok kümeleri üredi. // Etken ayrımı açısından morfolojik ipucu sağlar.

Tetkik 2: Transtorasik ekokardiyografi

Etiket: Transtorasik ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: Sağ kalp kapak tutulumunu destekler. | Sonuç yorumu: Sağ kalp kapak tutulumunu destekler. | Sonuç başlığı: Transtorasik ekokardiyografi | Sonuç özeti: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Yorum: Sağ kalp kapak tutulumunu destekler. | Satırlar: Transtorasik ekokardiyografi / Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. // Sağ kalp kapak tutulumunu destekler.

Tetkik 3: Toraks bilgisayarlı tomografi

Etiket: Toraks bilgisayarlı tomografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Periferik yerleşimli çoklu nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Klinik anlam: Septik pulmoner emboli ile uyumlu olabilir. | Sonuç yorumu: Septik pulmoner emboli ile uyumlu olabilir. | Sonuç başlığı: Toraks bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Periferik yerleşimli çoklu nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Yorum: Septik pulmoner emboli ile uyumlu olabilir. | Satırlar: Toraks bilgisayarlı tomografi / Periferik yerleşimli çoklu nodüler infiltrasyonlar izlendi. // Septik pulmoner emboli ile uyumlu olabilir.

Görseller

Görsel 1 ID: visual-018 | Başlık: Transtorasik ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: Sağ kalp kapak tutulumunu destekler. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/018_018-sag-kalp-vejetasyonu-ekokardiyografi.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/018_018-sag-kalp-vegetasyonu-ekokardiyografi.webp | Alt text: Transtorasik ekokardiyografi - Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready
Görsel 2: ID: visual-019 | Başlık: Toraks bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Periferik yerleşimli çoklu nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Klinik anlam: Septik pulmoner emboli ile uyumlu olabilir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/019_019-periferik-noduler-infiltrasyon-toraks-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/019_019-periferik-noduler-infiltrasyon-toraks-bt.webp | Alt text: Toraks bilgisayarlı tomografi - Periferik yerleşimli çoklu nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Staphylococcus aureus
- B) Streptococcus viridans
- C) Enterococcus faecalis
- D) Coxiella burnetii
- E) Candida albicans

Doğru Cevap: Staphylococcus aureus

A) Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus damar içi madde kullanımıyla ilişkili triküspit kapak endokarditinin en tipik etkenidir ve gram-pozitif kok kümeleriyle uyumludur. Vakadaki “Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Streptococcus viridans: Streptococcus viridans daha çok diş kaynaklı geçici bakteriyemi ve subakut sol kalp endokarditiyle ilişkilidir; gram-pozitif zincir yapısı beklenir. Bu olguda “Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Enterococcus faecalis: Enterococcus faecalis genitoüriner veya gastrointestinal kaynaklı endokarditte düşünülebilir ancak bu Vakadaki damar içi madde kullanımı ve kok kümeleri daha çok Staphylococcus aureus lehinedir. Bu olguda “Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Coxiella burnetii: Coxiella burnetii kültür negatif endokardit etkenidir; burada kan kültüründe gram-pozitif kok kümeleri bildirilmiştir. Bu olguda “Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Candida albicans: Candida albicans damar içi kateter veya immünsüpresyona ilişkili endokardit yapabilir ancak verilen mikrobiyolojik bulgu bakteri lehinedir. Bu olguda “Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Staphylococcus aureus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve yeni üfürüm olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.” ve “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Staphylococcus aureus seçeneği öne çıkar; “Kan kültüründe gram-pozitif kok kümeleri üremiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Damar içi madde kullanımı, triküspit kapak vejetasyonu, septik pulmoner emboli bulguları ve kan kültüründe gram-pozitif kok kümeleri sağ kalp enfektif endokarditini düşündürür. Bu klinik bağlamda en olası etken Staphylococcus aureus'tur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.”, “Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” ve “Kan kültüründe gram-pozitif kok kümeleri üremiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Staphylococcus aureus en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Damar içi madde kullanımı öyküsü sağ kalp kapak enfeksiyonu riskini artırır.

Kanıt 2: Triküspit kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.

Kanıt 3: Kan kültüründe gram-pozitif kok kümeleri üremiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Damar içi madde kullanıcısında triküspit endokarditi ve septik pulmoner emboli denince ilk etken Staphylococcus aureus düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 37: v166-new-037-pelvik-cerrahide-riskli-yapi

Başlık: Pelvik cerrahide riskli yapı

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi / Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Muayene bulgusunu anatomik yapı ve sinir-yapı ilişkisiyle eşleştirme.

Learning Target: Histerektomi sırasında ureterin uterin arterle anatomik ilişkisini belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, uzun süredir devam eden yoğun adet kanaması ve pelvik bası hissi nedeniyle kadın doğum polikliniğine başvuruyor. Son bir yılda adet kanamalarının arttığını, kansızlık nedeniyle demir tedavisi kullandığını ve doğurganlığını tamamladığını belirtiyor. Daha önce pelvik cerrahi geçirmemiştir.

Demografi: 48 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Bimanuel muayenede uterus iri ve düzensiz konturlu palpe edilir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Pelvik ultrasonografi

Etiket: Pelvik ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Uterus içinde çoklu intramural miyom nodülleri izlendi. | Klinik anlam: Cerrahi endikasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Cerrahi endikasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Pelvik ultrasonografi | Sonuç özeti: Uterus içinde çoklu intramural miyom nodülleri izlendi. | Yorum: Cerrahi endikasyonu destekler. | Satırlar: Pelvik ultrasonografi / Uterus içinde çoklu intramural miyom nodülleri izlendi. // Cerrahi endikasyonu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-020 | Başlık: Pelvik ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Uterus içinde çoklu intramural miyom nodülleri izlendi. | Klinik anlam: Cerrahi endikasyonu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/020_020-intramural-miyomlar-pelvik-ultrasonografi.webp | Thumbnail:

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Histerektomi sırasında uterin arter ligasyonu yapılırken yaralanma riski nedeniyle özellikle korunması gereken yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üreter
- B) Nervus obturatorius
- C) Arteria ovarica
- D) Ligamentum teres uteri
- E) Ductus deferens

Doğru Cevap: Üreter

A) Üreter: Üreter, uterin arterin altından geçtiği için histerektomi sırasında uterin arter ligasyonunda özellikle korunması gereken yapıdır. Vakadaki “Hastaya histerektomi planlanmaktadır.” ve “Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Nervus obturatorius: Nervus obturatorius lateral pelvik duvarla ilişkilidir; uterin arterin serviks yanındaki klasik komşuluğunu oluşturmaz. Bu olguda “Hastaya histerektomi planlanmaktadır.” ve “Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Üreter seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Arteria ovarica: Arteria ovarica over damar beslenmesiyle ilişkilidir ancak uterin arter ligasyonunda yaralanması en klasik olarak beklenen yapı değildir. Bu olguda “Hastaya histerektomi planlanmaktadır.” ve “Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Üreter seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Ligamentum teres uteri: Ligamentum teres uteri uterusun anterior-lateral bağlantılarından biridir; üreter yaralanması açısından ana riskli yapı değildir. Bu olguda “Hastaya histerektomi planlanmaktadır.” ve “Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Üreter seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Ductus deferens: Ductus deferens erkek üreme sistemine ait bir yapıdır ve kadın hastada histerektomi anatomisiyle ilişkili seçenek değildir. Bu olguda “Hastaya histerektomi planlanmaktadır.” ve “Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Üreter seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Pelvik cerrahide riskli yapı olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Hastaya histerektomi planlanmaktadır.” ve “Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.” birlikte okunduğunda Üreter seçeneği öne çıkar; “Risk, serviks lateralindeki pelvik anatomik komşulukla ilişkilidir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uterin arter serviks lateralinde üreterin üzerinden geçer. Histerektomi sırasında uterin arter bağlanırken bu yakın anatomik ilişki nedeniyle üreter yaralanması önemli bir cerrahi risktir. Bu olguda kararın temel ayırıcı, “Hastaya histerektomi planlanmaktadır.”, “Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.” ve “Risk, serviks lateralindeki pelvik anatomik komşulukla ilişkilidir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Üreter en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastaya histerektomi planlanmaktadır.

Kanıt 2: Cerrahide uterin arter ligasyonu gerekecektir.

Kanıt 3: Risk, serviks lateralindeki pelvik anatomik komşulukla ilişkilidir.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguyla uyumadığında elenir.

Exam Pearl: Pelvik cerrahide uterin arter üreterin üzerinden geçer; klasik ifade “water under the bridge” şeklindedir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 38: v166-new-038-gorme-yakinmasi-ve-metabolik-asidoz

Başlık: Görme yakınması ve metabolik asidoz

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Farmakoloji / Acil Tıp | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Metanol zehirlenmesinde fomepizolün mekanizmasını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, görme bulanıklığı, baş ağrısı ve kusma nedeniyle acile getiriliyor. Yakınları hastanın bir gün önce kaynağı belirsiz alkol tükettiğini, sabah saatlerinden itibaren bulanık görme ve karın ağrısı tariflediğini belirtiyor. Bilinen diyabet öyküsü yoktur.

Demografi: 39 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/62 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,12 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta konfüzedir
- Solunumu derin ve hızlıdır.
- Pupiller ışığa yavaş yanıt vermektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Toksik alkol maruziyetini destekler. | Sonuç yorumu: Toksik alkol maruziyetini destekler. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Toksik alkol maruziyetini destekler. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.18; HCO₃ 10; mmol/L / pH 7.35-7.45; HCO₃ 22-26 mmol/L / Toksik alkol maruziyetini destekler.

Tetkik 2: Serum osmolar açıklık

Etiket: Serum osmolar açıklık | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Artmış saptandı. | Klinik anlam: Toksik alkol varlığı açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Toksik alkol varlığı açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Serum osmolar açıklık | Sonuç özeti: Artmış saptandı. | Yorum: Toksik alkol varlığı açısından anlamlıdır. | Satırlar: Serum osmolar açıklık / 36 mOsm/kg / <10 mOsm/kg / Toksik alkol varlığı açısından anlamlıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-259 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Solunumu derin ve hızlıdır | Klinik anlam: Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi | URL:

https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/259_anxious_patient_in_medical_setting.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/259_anxious_patient_in_medical_setting.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Solunumu derin ve hızlıdır | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada fomepizolün temel tedavi edici mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi

- B) Asetaldehit dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi
C) Opioid reseptörlerini antagonize etmesi
D) Gama-aminobütirik asit reseptörlerini aktive etmesi
E) Formik asidi renal tübüllerden aktif olarak atması

Doğru Cevap: Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi

A) Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi: Alkol dehidrogenaz inhibisyonu, metanolün formik asit gibi toksik metabolitlere dönüşmesini engellediği için fomepizolün temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.” ve “Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Asetaldehit dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi: Asetaldehit dehidrogenaz inhibisyonu disülfiramın alkol kullanımındaki etkisidir; metanol toksisitesindeki ana hedef değildir. Bu olguda “Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.” ve “Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Opioid reseptörlerini antagonize etmesi: Opioid reseptör antagonizması naloksonun mekanizmasıdır ve bu Vakadaki metabolik asidoz ile görme toksisitesini açıklamaz. Bu olguda “Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.” ve “Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Gama-aminobütirik asit reseptörlerini aktive etmesi: Gama-aminobütirik asit reseptör aktivasyonu benzodiazepin veya barbitürat etkilileri ilişkilidir; toksik metabolit oluşumunu azaltmaz. Bu olguda “Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.” ve “Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Formik asidi renal tübüllerden aktif olarak atması: Formik asidin renal tübüllerden aktif atılımını artırmak fomepizolün mekanizması değildir; ilaç toksik metabolitin oluşumunu enzim düzeyinde azaltır. Bu olguda “Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.” ve “Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Görme yakınması ve metabolik asidoz olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.” ve “Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.” birlikte okunduğunda Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi seçeneği öne çıkar; “Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz ve artmış osmolar açıklık toksik alkol maruziyetini destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kaynağı belirsiz alkol alımı sonrası görme bozukluğu, yüksek anyon açıklı metabolik asidoz ve artmış osmolar açıklık metanol zehirlenmesini düşündürür. Fomepizol, alkol dehidrogenazı inhibe ederek metanolün toksik metabolitleri olan formaldehit ve formik aside dönüşmesini azaltır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.”, “Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.” ve “Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz ve artmış osmolar açıklık toksik alkol maruziyetini destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Alkol dehidrogenaz enzimini inhibe etmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kaynağı belirsiz alkol tüketiminden sonra yakınmalar başlamıştır.

Kanıt 2: Görme bulanıklığı ve pupiller yanıtın yavaşlaması optik toksisiteyi düşündürür.

Kanıt 3: Yüksek anyon açıklı metabolik asidoz ve artmış osmolar açıklık toksik alkol maruziyetini destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Metanol ve etilen glikol zehirlenmesinde fomepizol alkol dehidrogenazı inhibe ederek toksik metabolit oluşumunu azaltır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 39: v166-new-039-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu

Başlık: Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Hematoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Trombotik trombositopenik purpurada acil tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve ciltte morarmalar nedeniyle acile getiriliyor. Son üç gündür halsizlik ve aralıklı konuşma bozukluğu yaşadığı, son gün içinde burun kanaması ve yaygın morluklar geliştiği öğreniliyor. Antikoagülan kullanımı yoktur.

Demografi: 37 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 135/82 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 0,77

Fizik Muayene

- Hasta konfüzedir
- Alt ekstremitelerde ekimoz ve peteşiler mevcuttur.
- Meningeal irritasyon bulgusu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Anemi ve ağır trombositopeni saptandı. | Klinik anlam: Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir. | Sonuç yorumu: Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Anemi ve ağır trombositopeni saptandı. | Yorum: Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir. | Satırlar: Tam kan sayımı / Hb 7.9; trombosit 18.000 g/dL / mm³ / Hb 12-16 g/dL; trombosit 150.000-450.000 / mm³ / Kanama ve mikroanjyopatik süreç açısından önemlidir.

Tetkik 2: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yaygın şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik hemolitik anemi bulgusudur. | Sonuç yorumu: Mikroanjyopatik hemolitik anemi bulgusudur. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Yaygın şistositler izlendi. | Yorum: Mikroanjyopatik hemolitik anemi bulgusudur. | Satırlar: Periferik yayma / Yaygın şistositler izlendi. // Mikroanjyopatik hemolitik anemi bulgusudur.

Tetkik 3: Koagülasyon testleri

Etiket: Koagülasyon testleri | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı normal sınırlarda. | Klinik anlam: Yaygın damar içi pıhtılaşmadan ayırma yardımcıdır. | Sonuç yorumu: Yaygın damar içi pıhtılaşmadan ayırma yardımcıdır. | Sonuç başlığı: Koagülasyon testleri | Sonuç özeti: Protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı normal sınırlarda. | Yorum: Yaygın damar içi pıhtılaşmadan ayırma yardımcıdır. | Satırlar: Koagülasyon testleri / Protrombin zamanı ve aktive parsiyel tromboplastin zamanı normal sınırlarda. // Yaygın damar içi pıhtılaşmadan ayırma yardımcıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-021 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Yaygın şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik hemolitik anemi bulgusudur. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/021_021-yaygin-sistositler-periferik-yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/021_021-yaygin-sistositler-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Yaygın şistositler izlendi. | Asset durumu:

vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-260 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Alt ekstremitelerde ekimoz ve peteşiler mevcuttur | Klinik anlam: Terapötik plazma değişimi | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/260_legs_with_dermatologic_lesions_and_bruising.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/260_legs_with_dermatologic_lesions_and_bruising.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Alt ekstremitelerde ekimoz ve peteşiler mevcuttur | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada geciktirilmeden başlanması gereken temel tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Terapötik plazma değişimi
B) Profilaktik trombosit transfüzyonu
C) Düşük molekül ağırlıklı heparin
D) Yüksek doz kortikosteroid başlayıp plazma değişimini nörolojik bulgular gerilerse ertelemek
E) Acil splenektomi

Doğru Cevap: Terapötik plazma değişimi

A) Terapötik plazma değişimi: Terapötik plazma değişimi, trombotik trombositopenik purpurada eksik proteaz aktivitesini yerine koyup otoantiklorları uzaklaştırdığı için temel acil tedavidir. Vakadaki “Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.” ve “Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Profilaktik trombosit transfüzyonu: Profilaktik trombosit transfüzyonu mikrotrombüs oluşumunu artırabileceğinden rutin yaklaşım değildir ve yalnızca hayatı tehdit eden kanamada düşünülür. Bu olguda “Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.” ve “Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.” ipuçları tedavide önceliği açısından Terapötik plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Düşük molekül ağırlıklı heparin: Düşük molekül ağırlıklı heparin venöz tromboembolide kullanılır; burada temel sorun trombositopeniden zengin mikrovasküler trombozlar ve ilk tedavi değildir. Bu olguda “Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.” ve “Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.” ipuçları tedavide önceliği açısından Terapötik plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Yüksek doz kortikosteroid başlayıp plazma değişimini nörolojik bulgular gerilerse ertelemek: Oral demir tedavisi anemiyi açıklayan mikroanjyopatik hemolizi tedavi etmez ve acil nörolojik bulgulara yanıt sağlamaz. Bu olguda “Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.” ve “Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.” ipuçları tedavide önceliği açısından Terapötik plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Acil splenektomi: Vakadaki Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür ve Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur. Bu olguda “Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.” ve “Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.” ipuçları tedavide önceliği açısından Terapötik plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Trombositopeni ve nörolojik bulgu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.” ve “Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.” birlikte okunduğunda Terapötik plazma değişimi seçeneği öne çıkar; “Şistositler ve normal koagülasyon testleri mikroanjyopatik hemolizi destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Şistositli mikroanjyopatik hemolitik anemi, ağır trombositopeni, nörolojik bulgu ve normal koagülasyon testleri trombotik trombositopenik purpurayı düşündürür. Ölümcül seyir riski nedeniyle tedavi geciktirilmeden terapötik plazma değişimi başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.”, “Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.” ve “Şistositler ve normal koagülasyon testleri mikroanjyopatik hemolizi destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Terapötik plazma değişimi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğu nörolojik tutulumu düşündürür.

Kanıt 2: Ağır trombositopeni ile peteşi ve ekimozlar birlikte bulunur.

Kanıt 3: Şistositler ve normal koagülasyon testleri mikroanjyopatik hemolizi destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Trombotik trombositopenik purpurada acil tedavi terapötik plazma değişimidir; trombosit transfüzyonu rutin verilmez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 40: v166-new-040-kronik-halsizlik-ve-hipotansiyon

Başlık: Kronik halsizlik ve hipotansiyon

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Endokrinoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Öykü, muayene ve objektif verilerden en olası tanıya ulaşma.

Learning Target: Primer adrenal yetmezlikte beklenen elektrolit ve hormonal paterni yorumlayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, giderek artan halsizlik, kilo kaybı ve ayağa kalkınca baş dönmesi nedeniyle başvuruyor. Son altı ayda iştahsızlık ve tuzlu yiyeceklere belirgin istek geliştiğini belirtiyor. Zaman zaman bulantı ve karın ağrısı tarifliyor. Uzun süreli kortikosteroid kullanımı yoktur.

Demografi: 41 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/56 mmHg | Nabız: 98/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.6°C | Şok indeksi: 1,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta zayıf ve yorgun görünümündedir.
- Ağız mukozasında ve palmar çizgilerde hiperpigmentasyon mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumlu olabilir. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumlu olabilir. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumlu olabilir. | Satırlar: Serum sodyum / 128 mmol/L / 135-145 mmol/L | Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumlu olabilir.

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aldosteron eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: Aldosteron eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Aldosteron eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum potasyum / 5.8 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L | Aldosteron eksikliğini destekler.

Tetkik 3: Sabah kortizolü

Etiket: Sabah kortizolü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Glukokortikoid eksikliğini gösterir. | Sonuç yorumu: Glukokortikoid eksikliğini gösterir. | Sonuç başlığı: Sabah kortizolü | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Glukokortikoid eksikliğini gösterir. | Satırlar: Sabah kortizolü / 2.1 µg/dL / 5-25 µg/dL | Glukokortikoid eksikliğini gösterir.

Tetkik 4: Plazma ACTH

Etiket: Plazma ACTH | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Primer adrenal kaynaklı yetmezlik lehinedir. | Sonuç yorumu: Primer adrenal kaynaklı yetmezlik lehinedir. | Sonuç başlığı: Plazma ACTH | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Primer adrenal kaynaklı yetmezlik lehinedir. | Satırlar: Plazma ACTH / 310 pg/mL / 10-60 pg/mL / Primer adrenal kaynaklı yetmezlik lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-261 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Ağız mukozasında ve palmar çizgilerde hiperpigmentasyon mevcuttur | Klinik anlam: Primer adrenal yetmezlik | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/261_oral_and_palm_mucosa_examination_details.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/261_oral_and_palm_mucosa_examination_details.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Ağız mukozasında ve palmar çizgilerde hiperpigmentasyon mevcuttur | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Primer adrenal yetmezlik
B) Sekonder adrenal yetmezlik
C) Cushing sendromu
D) Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu
E) Hipertiroidi

Doğru Cevap: Primer adrenal yetmezlik

A) Primer adrenal yetmezlik: Primer adrenal yetmezlik düşük kortizol, yüksek ACTH, hiperpigmentasyon, hiponatremi ve hiperkalemi birlikteliğiyle bu olguda en uygun tanıdır. Vakadaki "Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçeklenir.
B) Sekonder adrenal yetmezlik: Sekonder adrenal yetmezlikte ACTH düşük veya uygunsuz normal olur ve mineralokortikoid eksikliği belirgin olmadığı için hiperkalemi beklenmez. Bu olguda "Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler." ipuçları tanısar karar açısından Primer adrenal yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Cushing sendromu: Cushing sendromunda kortizol fazlalığına bağlı kilo artışı, hipertansiyon ve hiperglisemi beklenir; bu hastada kortizol düşüktür. Bu olguda "Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler." ipuçları tanısar karar açısından Primer adrenal yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu: Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu hiponatremi yapabilir ancak hiperkalemi, hiperpigmentasyon ve düşük kortizol-yüksek ACTH paternini açıklamaz. Bu olguda "Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler." ipuçları tanısar karar açısından Primer adrenal yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Hipertiroidi: Hipertiroidi kilo kaybı ve taşikardi yapabilir fakat hiperkalemi, düşük kortizol ve yüksek ACTH ile uyumlu değildir. Bu olguda "Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler." ipuçları tanısar karar açısından Primer adrenal yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik halsizlik ve hipotansiyon olgusunda klinik karar tanısar karar üzerine kuruludur. "Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler." birlikte okunduğunda Primer adrenal yetmezlik seçeneği öne çıkar; "Düşük sabah kortizolüne rağmen ACTH yüksek bulunmuştur." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Halsizlik, kilo kaybı, ortostatik yakınmalar, tuz isteği, hiperpigmentasyon, hiponatremi, hiperkalemi, düşük kortizol ve yüksek ACTH primer adrenal yetmezliği destekler. Primer düzeyde adrenal korteks yetersiz olduğunda hem glukokortikoid hem mineralokortikoid eksikliği gelişir ve ACTH geri bildirim kaybıyla yükselir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür.", "Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler." ve "Düşük sabah kortizolüne rağmen ACTH yüksek bulunmuştur." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Primer adrenal yetmezlik en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hiperpigmentasyon yüksek ACTH etkisini düşündürür.

Kanıt 2: Hiponatremi ve hiperkalemi mineralokortikoid eksikliğini destekler.

Kanıt 3: Düşük sabah kortizolüne rağmen ACTH yüksek bulunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Primer adrenal yetmezlikte ACTH yüksektir; hiperpigmentasyon ve hiperkalemi sekonder adrenal yetmezlikten ayırmada önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 41: v167-new-041-bilinc-degisikligi-ve-solunum-baskılanmasi

Başlık: Bilinç değişikliği ve solunum baskılanması

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Acil Tıp / Toksikoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Opioid toksidromunda solunum depresyonuna yönelik antidotu seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, evde bilinç bulanıklığı ve yavaş solunum fark edilmesi üzerine ambulansla acile getiriliyor. Arkadaşları hastanın son saatlerde uyuşturucu madde kullandığını ve giderek uykuya meyilli hale geldiğini belirtiyor. Travma, ateş veya bilinen epilepsi öyküsü tariflenmiyor.

Demografi: 27 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 105/65 mmHg | Nabız: 58/dk | Solunum: 6/dk | SpO₂: %82% | Ateş: 36.6°C | Şok indeksi: 0,55

Fizik Muayene

- Hasta somnolandır ve ağırlı uyaranla kısa süreli yanıt vermektedir.
- Pupiller belirgin miyotiktir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hiperkapnik solunumsal asidoz saptandı. | Klinik anlam: Ventilasyon baskılanmasını destekler. | Sonuç yorumu: Ventilasyon baskılanmasını destekler. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Hiperkapnik solunumsal asidoz saptandı. | Yorum: Ventilasyon baskılanmasını destekler. | Satırlar: Arter kan gazı / PaCO₂ 68 mmHg / 35-45 mmHg / Ventilasyon baskılanmasını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ventilasyonu desteklerken uygulanması gereken özgül antidot aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Flumazenil
B) Nalokson
C) Atropin
D) Pralidoksim
E) Fomepizol

Doğru Cevap: Nalokson

A) Flumazenil: Flumazenil benzodiazepin etkisini antagonize eder; bu Vakadaki miyozis ve belirgin solunum depresyonu opioid toksidromunu daha iyi açıklar. Bu olguda “Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.” ve “Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nalokson: Nalokson opioid reseptör antagonisti olarak bilinç baskılanması ve solunum depresyonunu hedeflediği için bu hastada özgül antidottur. Vakadaki “Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.” ve “Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Atropin: Atropin muskarinik bulguları azaltır ancak opioid reseptör aracılı solunum baskılanmasını düzeltmez. Bu olguda “Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.” ve “Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pralidoksim: Pralidoksim organofosfat zehirlenmesinde asetilkolinesterazı yeniden aktive eder; bu olguda kolinerjik toksidrom bulguları yoktur. Bu olguda “Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.” ve “Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Fomepizol: Fomepizol metanol veya etilen glikol zehirlenmelerinde alkol dehidrogenazı inhibe eder; bu hastadaki toksidromla uyumlu değildir. Bu olguda “Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.” ve “Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bilinç değişikliği ve solunum baskılanması olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.” ve “Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.” birlikte okunduğunda Nalokson seçeneği öne çıkar; “Solunum sayısının 6/dk olması ve hiperkapni ventilasyon depresyonunu gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bilinç baskılanması, miyozis ve belirgin solunum depresyonu opioid toksidromunu düşündürür. Bu tabloda hava yolu ve ventilasyon desteğiyle birlikte opioid reseptör antagonisti nalokson uygulanmalıdır; amaç solunum depresyonunu hızla geri çevirmektir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.”, “Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.” ve “Solunum sayısının 6/dk olması ve hiperkapni ventilasyon depresyonunu gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nalokson en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Uyuşturucu madde kullanımı sonrası bilinç baskılanması gelişmiştir.

Kanıt 2: Belirgin miyozis opioid toksidromu ile uyumludur.

Kanıt 3: Solunum sayısının 6/dk olması ve hiperkapni ventilasyon depresyonunu gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Opioid zehirlenmesinde hayatı tehdit eden bulgu solunum depresyonudur; özgül antidot naloksondur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 42: v167-new-042-asidoz-ve-hiperglisemi-tablosu

Başlık: Asidoz ve hiperglisemi tablosu

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Dahiliye / Endokrinoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Diyabetik ketoasidozda potasyum düzeyine göre insülin öncesi yaklaşımı belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bulantı, karın ağrısı ve hızlı nefes alma nedeniyle acile başvuruyor. Son iki gündür insülin dozlarını aksattığını, çok su içme ve sık idrara çıkma yakınmalarının arttığını belirtiyor. Ateş veya yeni ilaç kullanımı tariflemiyor.

Demografi: 19 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 95/60 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,28 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta dehidrate ve halsiz görünümündedir.
- Derin ve hızlı solunum mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum glukoz

Etiket: Serum glukoz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hiperglisemik krizle uyumludur. | Sonuç yorumu: Hiperglisemik krizle uyumludur. | Sonuç başlığı: Serum glukoz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hiperglisemik krizle uyumludur. | Satırlar: Serum glukoz / 486 mg/dL / 70-140 mg/dL / Hiperglisemik krizle uyumludur.

Tetkik 2: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Ketoasidoz şiddetini gösterir. | Sonuç yorumu: Ketoasidoz şiddetini gösterir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Ketoasidoz şiddetini gösterir. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.12 / 7.35-7.45 / Ketoasidoz şiddetini gösterir.

Tetkik 3: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: İnsülin tedavisi öncesi kritik güvenlik parametresidir. | Sonuç yorumu: İnsülin tedavisi öncesi kritik güvenlik parametresidir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum / 3.0 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / İnsülin tedavisi öncesi kritik güvenlik parametresidir.

Tetkik 4: İdrar ketonu

Etiket: İdrar ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Keton üretimini destekler. | Sonuç yorumu: Keton üretimini destekler. | Sonuç başlığı: İdrar ketonu | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Keton üretimini destekler. | Satırlar: İdrar ketonu / Pozitif saptandı. // Keton üretimini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-262 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Derin ve hızlı solunum mevcuttur. | Klinik anlam: Potasyum replasmanı yapılması | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/262_patient_in_hospital_with_medical_equipment.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/262_patient_in_hospital_with_medical_equipment.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Derin ve hızlı solunum mevcuttur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada sıvı desteği başlandıktan sonra insülin infüzyonuna geçmeden önce yapılması gereken en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz bikarbonat verilmesi
B) Potasyum replasmanı yapılması
C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanması
D) Mannitol infüzyonu başlanması
E) Acil hemodiyaliz uygulanması

Doğru Cevap: Potasyum replasmanı yapılması

A) İntravenöz bikarbonat verilmesi: İntravenöz bikarbonat yalnızca çok ağır asidoz gibi seçilmiş durumlarda düşünülür; burada öncelikli güvenlik sorunu düşük potasyumdur. Bu olguda "İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir." ve "Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Potasyum replasmanı yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Potasyum replasmanı yapılması: Potasyum replasmanı düşük serum potasyumu varlığında insülinin oluşturacağı hücre içi potasyum kaymasını güvenli hale getirmek için gereklidir. Vakadaki "İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir." ve "Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanması: Subkutan hızlı etkili insülin potasyum düşüken hipokalemiyi ağırlaştırabilir ve bu nedenle uygun ilk yaklaşım değildir. Bu olguda "İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir." ve "Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Potasyum replasmanı yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Mannitol infüzyonu başlanması: Mannitol serebral ödem gibi özel komplikasyonlarda kullanılır; bu hastada insülin öncesi karar potasyum düzeyine göre verilmelidir. Bu olguda "İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir." ve "Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Potasyum replasmanı yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Acil hemodiyaliz uygulanması: Acil hemodiyaliz bu klinik tabloda rutin ilk yaklaşım değildir; elektrolit güvenliği ve sıvı-insülin tedavi sırası önceliklidir. Bu olguda "İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir." ve "Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Potasyum replasmanı yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Asidoz ve hiperglisemi tablosu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir." ve "Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler." birlikte okunduğunda Potasyum replasmanı yapılması seçeneği öne çıkar; "Serum potasyumunun 3.0 mmol/L olması insülin öncesi hipokalemi riskini gösterir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Diyabetik ketoasidozda toplam vücut potasyumu azalmıştır ve insülin potasyumu hücre içine sokarak hipokalemiyi ağırlaştırabilir. Serum potasyumu düşük olan hastada insülin başlamadan önce potasyum replasmanı yapılmalı, aritmi ve solunum kas güçsüzlüğü riski azaltılmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.", "Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler." ve "Serum potasyumunun 3.0 mmol/L olması insülin öncesi hipokalemi riskini gösterir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Potasyum replasmanı yapılması en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: İnsülin dozlarının aksamaması sonrası hiperglisemi ve ketonüri gelişmiştir.

Kanıt 2: Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu destekler.

Kanıt 3: Serum potasyumunun 3.0 mmol/L olması insülin öncesi hipokalemi riskini gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Diyabetik ketoasidozda potasyum düşükse insülin ertelenir ve önce potasyum replasmanı yapılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 43: v167-new-043-premature-bebekte-solunum-sikintisi

Başlık: Prematüre bebekte solunum sıkıntısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Neonatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Yenidoğanda respiratuvar distres sendromunun temel patofizyolojisini ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebekte doğumdan kısa süre sonra inleme, takipne ve çekilmeler geliyor. Anne erken membran rüptürü olmadan spontan erken doğum yapmıştır. Antenatal steroid uygulamasının tamamlanamadığı öğreniliyor. Doğum ağırlığı gebelik haftasına uygundur.

Demografi: 30. gebelik haftasında doğan erkek yenidoğan | Setting: Doğum salonu

Vital Bulgular

Kan basıncı: 62/38 mmHg | Nabız: 158/dk | Solunum: 72/dk | SpO₂: %86% | Ateş: 36.5°C | Şok indeksi: 2,55 (yüksek)

Fizik Muayene

- Yenidoğanda burun kanadı solunumu, interkostal çekilmeler ve ekspiratuvar inleme vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izleniyor. | Klinik anlam: Prematüre solunum sıkıntısı tablosunu destekler. | Sonuç yorumu: Prematüre solunum sıkıntısı tablosunu destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izleniyor. | Yorum: Prematüre solunum sıkıntısı tablosunu destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izleniyor. / / Prematüre solunum sıkıntısı tablosunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-022 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izleniyor. | Klinik anlam: Prematüre solunum sıkıntısı tablosunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/022_022-premature-rds-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/022_022-premature-rds-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izleniyor. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki temel patofizyolojik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması
- B) Mezodermal akciğer tomurcuğunun gelişememesi
- C) Pulmoner venöz dönüşün sol atriya ulaşamaması
- D) Terminal bronşiollerde mukus tıkaçları oluşması
- E) Fetal akciğer sıvısının lenfatik drenajının kalıcı olarak artması

Doğru Cevap: Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması

A) Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması: Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması prematüre respiratuvar distres sendromunun temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.” ve “Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Mezodermal akciğer tomurcuğunun gelişememesi: Mezodermal akciğer tomurcuğunun gelişememesi embriyolojik ağır malformasyonları düşündürür; bu klinik ve grafi paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.” ve “Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Pulmoner venöz dönüşün sol atriya ulaşamaması: Pulmoner venöz dönüş anomalileri kardiyak siyanoz nedeni olabilir ancak prematüre doğum ve retikülogranüler akciğer paterniyle açıklanmaz. Bu olguda “Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.” ve “Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Terminal bronşiollerde mukus tıkaçları oluşması: Terminal bronşiollerde mukus tıkaçları astım veya bronşiolit gibi hava yolu hastalıklarında beklenir; yenidoğanın temel sorunu alveoler stabiliteyi. Bu olguda “Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.” ve “Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Fetal akciğer sıvısının lenfatik drenajının kalıcı olarak artması: Fetal akciğer sıvısının geç temizlenmesi transient takipne ile ilişkilidir; bu seçenek yüzey gerilimi artışı ve atelektazi mekanizmasını açıklamaz. Bu olguda “Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.” ve “Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Prematüre bebekte solunum sıkıntısı olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.” ve “Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” birlikte okunduğunda Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması seçeneği öne çıkar; “Akciğer grafisinde bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Prematüre doğum, antenatal steroidin tamamlanmaması, doğumdan kısa süre sonra başlayan solunum sıkıntısı ve grafide retikülogranüler görünüm neonatal respiratuvar distres sendromunu düşündürür. Temel mekanizma tip II pnömosit olgunlaşmasının yetersizliği sonucu surfaktan eksikliği, alveoler yüzey gerilimi artışı ve atelektazidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.”, “Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Akciğer grafisinde bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Alveoler surfaktan eksikliğine bağlı yüzey geriliminin artması en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Bebek 30. gebelik haftasında prematüre doğmuştur.

Kanıt 2: Solunum sıkıntısı doğumdan kısa süre sonra başlamıştır.

Kanıt 3: Akciğer grafisinde bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlenmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Prematüre yenidoğanda erken solunum sıkıntısının temel nedeni surfaktan eksikliğine bağlı alveoler kollapstır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 44: v167-new-044-uzamis-ates-ve-ufurum

Başlık: Uzamış ateş ve üfürüm

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Enfeksiyon Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik bağlam ve mikrobiyolojik ipuçlarıyla olası etkeni belirleme.

Learning Target: Subakut endokarditte etkeni klinik bağlam ve kültür sonucu ile ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, üç haftadır süren ateş, gece terlemesi ve halsizlik nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık bir ay önce diş çekimi yaptırdığı, son haftalarda kilo kaybı ve iştahsızlık geliştiği öğreniliyor. Bilinen mitral kapak prolapsusu öyküsü vardır.

Demografi: 58 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 120/70 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,80

Fizik Muayene

- Kardiyak oskültasyonda apikal sistolik üfürüm duyulur.
- Avuç içlerinde ağrısız eritemli maküller izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan kültürü

Etiket: Kan kültürü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Viridans grup streptokok üredi. | Klinik anlam: Subakut kapak enfeksiyonu için anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Subakut kapak enfeksiyonu için anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Kan kültürü | Sonuç özeti: Viridans grup streptokok üredi. | Yorum: Subakut kapak enfeksiyonu için anlamlıdır. | Satırlar: Kan kültürü / Viridans grup streptokok üredi. // Subakut kapak enfeksiyonu için anlamlıdır.

Tetkik 2: Transtorasik ekokardiyografi

Etiket: Transtorasik ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: Endovasküler enfeksiyon odağını gösterir. | Sonuç yorumu: Endovasküler enfeksiyon odağını gösterir. | Sonuç başlığı: Transtorasik ekokardiyografi | Sonuç özeti: Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Yorum: Endovasküler enfeksiyon odağını gösterir. | Satırlar: Transtorasik ekokardiyografi / Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. // Endovasküler enfeksiyon odağını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-023 | Başlık: Transtorasik ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: Endovasküler enfeksiyon odağını gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/023_023-mitral-vejetasyon-ekokardiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/023_023-mitral-vejetasyon-ekokardiyografi.webp | Alt text: Transtorasik ekokardiyografi - Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-263 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Avuç içlerinde ağrısız eritemli maküller izlenir. | Klinik anlam: Streptococcus viridans | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/263_examining_open_palms_with_skin_details.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/263_examining_open_palms_with_skin_details.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Avuç içlerinde ağrısız eritemli

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Staphylococcus aureus
- B) Streptococcus pyogenes
- C) Streptococcus viridans
- D) Enterococcus faecalis
- E) Candida albicans

Doğru Cevap: Streptococcus viridans

A) Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus daha çok akut, agresif seyirli endokardit ve intravenöz ilaç kullanımıyla ilişkilidir; bu olguda subakut dental kaynak ön plandadır. Bu olguda “Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.” ve “Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.” ipuçları tanısız karar açısından Streptococcus viridans seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Streptococcus pyogenes: Streptococcus pyogenes farenjit ve yumuşak doku enfeksiyonlarında önemlidir ancak dental işlem sonrası subakut kapak enfeksiyonunun klasik etkeni değildir. Bu olguda “Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.” ve “Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.” ipuçları tanısız karar açısından Streptococcus viridans seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Streptococcus viridans: Streptococcus viridans ağız florası kaynaklı bakteriyemi sonrası hasarlı doğal kapakta subakut endokardit yapmasıyla bu olguda en uygun etkindir. Vakadaki “Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.” ve “Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Enterococcus faecalis: Enterococcus faecalis genitoüriner veya gastrointestinal girişimler sonrası endokardit yapabilir; burada dental işlem ve viridans kültür sonucu daha belirleyicidir. Bu olguda “Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.” ve “Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.” ipuçları tanısız karar açısından Streptococcus viridans seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Candida albicans: Candida albicans özellikle santral kateter, immünsüpresyon veya protez kapak zemininde düşünülür; bu olgunun kültür ve klinik bağlamıyla uyumlu değildir. Bu olguda “Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.” ve “Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.” ipuçları tanısız karar açısından Streptococcus viridans seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzamış ateş ve üfürüm olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.” ve “Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.” birlikte okunduğunda Streptococcus viridans seçeneği öne çıkar; “Ekokardiyografide mitral kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hasarlı doğal kapak, dental işlem sonrası subakut ateşli seyir ve kan kültüründe viridans grup streptokok üremesi subakut enfektif endokardit için tipiktir. Streptococcus viridans ağız florasından geçici bakteriyemiyle kapak yüzeyine tutunabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.”, “Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.” ve “Ekokardiyografide mitral kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Streptococcus viridans en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Diş çekimi sonrası haftalar içinde uzamış ateş ve halsizlik gelişmiştir.

Kanıt 2: Mitral kapak prolapsusu hasarlı kapak zeminini oluşturur.

Kanıt 3: Ekokardiyografide mitral kapakta hareketli vejetasyon izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Dental işlem sonrası hasarlı doğal kapakta subakut endokardit denince viridans streptokoklar akla gelmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 45: v167-new-045-yavas-ilerleyen-hareket-bozuklugu

Başlık: Yavaş ilerleyen hareket bozukluğu

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Nöroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloyu morfolojik veya histopatolojik paternle ilişkilendirme.

Learning Target: Parkinson hastalığında nigrostriatal dopaminerjik nöron kaybını klinikle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ elde titreme ve hareketlerde yavaşlama nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık bir yıldır istirahat sırasında belirginleşen el titremesi olduğunu, düğme ilikleme ve yazı yazma gibi işlerde yavaşladığını belirtiyor. Aile, yürürken kol salınımının azaldığını fark etmiştir.

Demografi: 64 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ elde istirahat tremoru, bilateral rijidite ve bradikinezi mevcuttur.
- Yürüyüş küçük adımlıdır ve postür hafif öne eğiktir.
- Bilinç ve temel duyu muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta temel olarak hangi anatomik-patolojik değişiklik beklenir?

- A) Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp
- B) Hippokampus CA1 bölgesinde akut iskemik nekroz
- C) Alt motor nöronlarda ön boynuz hücre kaybı
- D) Serebellar Purkinje hücrelerinde selektif kayıp
- E) Kaudat çekirdekte belirgin GABAerjik nöron kaybı

Doğru Cevap: Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp

A) Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp: Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp, istirahat tremoru, rijidite ve bradikineziyle seyreden bu tablonun temel patolojisidir. Vakadaki "İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir." ve "Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Hippokampus CA1 bölgesinde akut iskemik nekroz: Hippokampus CA1 bölgesinde akut iskemik nekroz daha çok hipoksik-iskemik hasarla ilişkilidir ve parkinsonizm bulgularını açıklamaz. Bu olguda "İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir." ve "Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Alt motor nöronlarda ön boynuz hücre kaybı: Alt motor nöron ön boynuz hücre kaybı kas güçsüzlüğü, atrofi ve fasikülasyonla seyreder; burada ekstrapiramidal bulgular ön plandadır. Bu olguda "İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir." ve "Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Serebellar Purkinje hücrelerinde selektif kayıp: Serebellar Purkinje hücre kaybı ataksi ve koordinasyon bozukluğu yapar; istirahat tremoru ve bradikinezi için temel mekanizma değildir. Bu olguda "İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir." ve "Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kaudat çekirdekte belirgin GABAerjik nöron kaybı: Kaudat çekirdekte belirgin GABAerjik nöron kaybı Huntington hastalığıyla ilişkilidir ve koreiform hareketler beklenir. Bu olguda "İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir." ve "Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yavaş ilerleyen hareket bozukluğu olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir." ve "Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır." birlikte okunduğunda Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp seçeneği öne çıkar; "Küçük adımlı yürüyüş ve kol salınımında azalma bazal ganglion motor devre etkilenmesini düşündürür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İstirahat tremoru, rijidite, bradikinezi ve postür-yürüyüş değişiklikleri Parkinson hastalığını düşündürür. Temel patolojik değişiklik substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarının kaybidir; bu kayıp striatal dopamin azalmasına ve bazal ganglion devrelerinde hareket başlatmanın zorlaşmasına neden olur. Bu olguda kararın temel ayrımı; "İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir.", "Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır." ve "Küçük adımlı yürüyüş ve kol salınımında azalma bazal ganglion motor devre etkilenmesini düşündürür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöronlarında kayıp en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: İstirahat sırasında belirginleşen el titremesi tariflenmiştir.

Kanıt 2: Muayenede rijidite ve bradikinezi saptanmıştır.

Kanıt 3: Küçük adımlı yürüyüş ve kol salınımında azalma bazal ganglion motor devre etkilenmesini düşündürür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Parkinson hastalığında temel lezyon substantia nigra pars compacta dopaminerjik nöron kaybidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 46: v167-new-046-gebelikte-hipertansif-tablo

Başlık: Gebelikte hipertansif tablo

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Preeklampside ciddi özellik varlığında uygun doğum kararını belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nedeniyle başvuruyor. Son hafta ellerinde ve yüzünde şişlik fark ettiğini, bugün baş ağrısının analjezikle geçmediğini belirtiyor. Daha önce hipertansiyon tanısı olmadığını ifade ediyor.

Demografi: 34 yaşında gebe hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 160/100 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,57

Fizik Muayene

- Hasta huzursuz görünümündedir.
- Pretibial ödem mevcuttur.
- Sağ üst kadranda hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar protein/kreatinin oranı

Etiket: İdrar protein/kreatinin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Proteinürinin varlığını destekler. | Sonuç yorumu: Proteinürinin varlığını destekler. | Sonuç başlığı: İdrar protein/kreatinin oranı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Proteinürinin varlığını destekler. | Satırlar: İdrar protein/kreatinin oranı / 0.8 / <0.3 / Proteinürinin varlığını destekler.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Ciddi özellik açısından önemlidir. | Sonuç yorumu: Ciddi özellik açısından önemlidir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Ciddi özellik açısından önemlidir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 85.000 /mm³ / 150.000-400.000 /mm³ / Ciddi özellik açısından önemlidir.

Tetkik 3: Serum AST

Etiket: Serum AST | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hepatik etkilenmeyi gösterir. | Sonuç yorumu: Hepatik etkilenmeyi gösterir. | Sonuç başlığı: Serum AST | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hepatik etkilenmeyi gösterir. | Satırlar: Serum AST / 92 U/L / <35 U/L / Hepatik etkilenmeyi gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

- Ayaktan kan basıncı izlemi ve bir hafta sonra kontrol
- Oral antihipertansif başlanarak gebeliğin 40. haftaya kadar sürdürülmesi
- Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi
- Antihipertansif tedavi ve antenatal kortikosteroid sonrası gebeliği yakın servis izlemiyle uzatmaya çalışmak

E) Proteinüri kaybolana kadar doğumun ertelenmesi

Doğru Cevap: Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi

A) Ayaktan kan basıncı izlemi ve bir hafta sonra kontrol: Ayaktan izlem ağır hipertansiyon, nörolojik semptom ve laboratuvar ciddi özellikleri olan gebede güvenli değildir. Bu olguda “Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.” ve “Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Oral antihipertansif başlanarak gebeliğin 40. haftaya kadar sürdürülmesi: Oral antihipertansif başlanarak gebeliğin 40. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür ve Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir. Bu olguda “Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.” ve “Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi: Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğum, 35 haftalık ciddi özellikli preeklampside anne ve fetus için en uygun yöntemdir. Vakadaki “Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.” ve “Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

D) Antihipertansif tedavi ve antenatal kortikosteroid sonrası gebeliği yakın servis izlemiyle uzatmaya çalışmak: Vakadaki Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür ve Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir. Bu olguda “Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.” ve “Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Proteinüri kaybolana kadar doğumun ertelenmesi: Proteinürinin kaybolmasını beklemek preeklampsinin doğal seyriyle uyumlu değildir ve ciddi maternal komplikasyon riskini gereksiz artırır. Bu olguda “Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.” ve “Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte hipertansif tablo olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.” ve “Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.” birlikte okunduğunda Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi seçeneği öne çıkar; “Trombosit düşüklüğü ve AST yüksekliği maternal organ etkilenmesini destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu olguda 20. gebelik haftasından sonra yeni başlayan ağır hipertansiyon, proteinüri, nörolojik semptom, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği ciddi özellikli preeklampsiyi düşündürür. Otuz dört haftadan büyük gebelikte anne stabilizasyonu, nöbet profilaksisi için magnezyum sülfat, kan basıncı kontrolü ve ardından doğum en uygun yaklaşımdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.”, “Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.” ve “Trombosit düşüklüğü ve AST yüksekliği maternal organ etkilenmesini destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Magnezyum sülfat ve kan basıncı kontrolü sonrası doğumun gerçekleştirilmesi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Gebeliğin 35. haftasında kan basıncı 170/112 mmHg ölçülmüştür.

Kanıt 2: Şiddetli baş ağrısı ve bulanık görme nörolojik ciddi özellikleri gösterir.

Kanıt 3: Trombosit düşüklüğü ve AST yüksekliği maternal organ etkilenmesini destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ciddi özellikli preeklampside 34 hafta sonrası temel yaklaşım maternal stabilizasyon ve doğumdur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 47: v167-new-047-ates-ve-sag-ust-kadran-agrisi

Başlık: Ateş ve sağ üst kadran ağrısı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi / Gastroenteroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Akut kolanjitte Charcot triadı ve obstrüksiyon bulgularıyla uygun ilk kaynak kontrolünü seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, titreme ve sağ üst kadran ağrısı nedeniyle acile başvuruyor. İki gündür aralıklı sağ üst kadran ağrısı olduğunu, bugün titreme ve gözlerde sararma fark edildiğini belirtiyor. Daha önce safra taşı tanısı aldığı öğreniliyor.

Demografi: 72 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/60 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 39.1°C | Şok indeksi: 1,18 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta toksik görünümündedir.
- Skleralarda ikter ve sağ üst kadranda hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Total bilirubin

Etiket: Total bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kolestazi destekler. | Sonuç yorumu: Kolestazi destekler. | Sonuç başlığı: Total bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kolestazi destekler. | Satırlar: Total bilirubin / 6.4 mg/dL / 0.2-1.2 mg/dL / Kolestazi destekler.

Tetkik 2: Alkalen fosfataz

Etiket: Alkalen fosfataz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Alkalen fosfataz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Satırlar: Alkalen fosfataz / 480 U/L / 40-130 U/L / Safra yolu obstrüksiyonunu destekler.

Tetkik 3: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Koledok dilate izleniyor ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak görülüyor. | Klinik anlam: Obstrüktif odağı gösterir. | Sonuç yorumu: Obstrüktif odağı gösterir. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Koledok dilate izleniyor ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak görülüyor. | Yorum: Obstrüktif odağı gösterir. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Koledok dilate izleniyor ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak görülüyor. / / Obstrüktif odağı gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-024 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Koledok dilate izleniyor ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak görülüyor. | Klinik anlam: Obstrüktif odağı gösterir. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/024_024-dilate-koledok-ve-distal-tas-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/024_024-dilate-koledok-ve-distal-tas-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Koledok dilate izleniyor ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak görülüyor. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-264 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Skleralarda ikter ve sağ üst kadranda hassasiyet vardır. | Klinik anlam: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/264_hospital_exam_room_with_elderly_woman.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/264_hospital_exam_room_with_elderly_woman.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Skleralarda ikter ve sağ üst kadranda hassasiyet vardır. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Antibiyotik ve sıvı desteği başlanan bu hastada en uygun kaynak kontrol yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Elektif kolesistektomi için poliklinik takibi
- B) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı
- C) Oral safra asidi tedavisi başlanması
- D) Analjezik tedaviyle izlem
- E) Tanısal laparoskopi ile apendiks değerlendirilmesi

Doğru Cevap: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı

A) Elektif kolesistektomi için poliklinik takibi: Elektif kolesistektomi akut enfekte obstrüksiyonu hemen çözmez ve sepsis riski olan hastada kaynak kontrolünü geciktirir. Bu olguda “Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.” ve “Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı taşla tıkanmış enfekte koledokta en uygun kaynak kontrol yaklaşımıdır. Vakadaki “Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.” ve “Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Oral safra asidi tedavisi başlanması: Oral safra asidi tedavisi akut koledok obstrüksiyonu ve enfeksiyonda yeterli veya hızlı etkili bir tedavi değildir. Bu olguda “Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.” ve “Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Analjezik tedaviyle izlem: Vakadaki Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur ve Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir. Bu olguda “Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.” ve “Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Tanısal laparoskopi ile apendiks değerlendirilmesi: Tanısal laparoskopi ile apendiks değerlendirilmesi sağ alt kadranda patolojileri için düşünülebilir; bu olguda safra yolu kaynaklı bulgular belirgindir. Bu olguda “Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.” ve “Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve sağ üst kadranda ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.” ve “Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.” birlikte okunduğunda Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide dilate koledok ve distal koledok taşı izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter Charcot triadını oluşturur; laboratuvar ve ultrason bulguları koledok obstrüksiyonunu destekler. Akut kolanjitte antibiyotik ve sıvı desteğine ek olarak enfekte obstrükte safra yolunun endoskopik drenajı kaynak kontrolü sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.”, “Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.” ve “Ultrasonografide dilate koledok ve distal koledok taşı izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile safra yolu drenajı en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ateş, titreme, sağ üst kadranda ağrısı ve ikter birlikte mevcuttur.

Kanıt 2: Bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekliği kolestatik paterni gösterir.

Kanıt 3: Ultrasonografide dilate koledok ve distal koledok taşı izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Akut kolanjitte antibiyotik destek tedavidir; obstrüksiyon varsa temel kaynak kontrolü safra yolu drenajıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 48: v167-new-048-hemoliz-ve-norolojik-bulgular

Başlık: Hemoliz ve nörolojik bulgular

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Hematoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Öykü, muayene ve objektif verilerden en olası tanıya ulaşma.

Learning Target: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeniyle trombotik trombositopenik purpurayı ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, baş ağrısı, dalgınlık ve yaygın morarma nedeniyle acile başvuruyor. Son üç gündür halsizlik ve aralıklı konuşma bozukluğu atakları olduğu, belirgin kanlı ishal öyküsü bulunmadığı öğreniliyor. Yeni ilaç kullanımı veya bilinen karaciğer hastalığı yoktur.

Demografi: 38 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 130/80 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 37.9°C | Şok indeksi: 0,80

Fizik Muayene

- Hasta intermittan konfüzidir.
- Ciltte yaygın peteşiler vardır.
- Belirgin ense sertliği yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Anemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Anemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Anemiyi gösterir. | Satırlar: Hemoglobin / 8.4 g/dL / 12-16 g/dL / Anemiyi gösterir.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Trombositopeni ciddidir. | Sonuç yorumu: Trombositopeni ciddidir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Trombositopeni ciddidir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 18.000 /mm³ / 150.000-400.000 /mm³ / Trombositopeni ciddidir.

Tetkik 3: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjiyopatik hemolizi destekler. | Sonuç yorumu: Mikroanjiyopatik hemolizi destekler. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Şistositler izlendi. | Yorum: Mikroanjiyopatik hemolizi destekler. | Satırlar: Periferik yayma / Şistositler izlendi. / / Mikroanjiyopatik hemolizi destekler.

Tetkik 4: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hafif yüksek saptandı. | Klinik anlam: Organ etkilenmesi açısından izlenmelidir. | Sonuç yorumu: Organ etkilenmesi açısından izlenmelidir. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Hafif yüksek saptandı. | Yorum: Organ etkilenmesi açısından izlenmelidir. | Satırlar: Serum kreatinin / 1.4 mg/dL

Görseller

Görsel 1: ID: visual-025 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjiyopatik hemolizi destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/025_025-sistositler-periferik-yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/025_025-sistositler-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Şistositler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-265 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Ciltte yaygın peteşiler vardır. | Klinik anlam: Trombotik trombositopenik purpura | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/265_petechial_rash_on_limbs_and_hands.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/265_petechial_rash_on_limbs_and_hands.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Ciltte yaygın peteşiler vardır. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İmmün trombositopeni
B) Trombotik trombositopenik purpura
C) Hemofili A
D) Demir eksikliği anemisi
E) Akut lenfoblastik lösemi

Doğru Cevap: Trombotik trombositopenik purpura

A) İmmün trombositopeni: İmmün trombositopeni izole trombositopeni yapar; şistositli mikroanjiyopatik hemoliz ve nörolojik bulguları açıklamaz. Bu olguda “Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları tanısall karara açısından Trombotik trombositopenik purpura seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Trombotik trombositopenik purpura: Trombotik trombositopenik purpura trombositopeni, şistositli hemoliz ve nörolojik dalgalanma ile bu olguda en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Hemofili A: Hemofili A pıhtılaşma faktörü eksikliğine bağlı derin doku kanamalarıyla seyreder; trombositopeni ve şistosit beklenmez. Bu olguda “Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları tanısall karara açısından Trombotik trombositopenik purpura seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği anemisi mikrositer anemi yapabilir ancak ağır trombositopeni, şistosit ve akut nörolojik atakları açıklamaz. Bu olguda “Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları tanısall karara açısından Trombotik trombositopenik purpura seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Akut lenfoblastik lösemi: Akut lenfoblastik lösemi sitopenilerle gelebilir ancak verilen periferik yayma bulgusu mikroanjiyopatik süreci daha doğrudan destekler. Bu olguda “Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ipuçları tanısall karara açısından Trombotik trombositopenik purpura seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hemoliz ve nörolojik bulgular olgusunda klinik karar tanısall karara üzerine kuruludur. “Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” birlikte okunduğunda Trombotik trombositopenik purpura seçeneği öne çıkar; “Dalgınlık ve konuşma bozukluğu atakları nörolojik etkilenmeyi destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Trombositopeni, mikroanjiyopatik hemolitik anemi bulgusu olan şistositler, nörolojik dalgalanma ve hafif renal etkilenme trombotik trombositopenik purpurayı düşündürür. Bu tablo ADAMTS13 aktivitesinin azalmasıyla büyük von Willebrand faktör multimerlerinin birikmesine ve mikrotrombüslere bağlıdır. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.”, “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.” ve “Dalgınlık ve konuşma bozukluğu atakları nörolojik etkilenmeyi destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Trombotik trombositopenik purpura en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Yaygın peteşilerle birlikte trombosit sayısı belirgin düşüktür.

Kanıt 2: Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi gösterir.

Kanıt 3: Dalgınlık ve konuşma bozukluğu atakları nörolojik etkilenmeyi destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Trombositopeni, şistosit ve nörolojik bulgu birlikteliğinde trombotik trombositopenik purpura acil düşünülmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 49: v167-new-049-kolik-yan-agrisi

Başlık: Kolik yan ağrısı

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Üroloji / Nefroloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Objektif verileri doğru yorumlayarak karara verdirci bulguyu seçme.

Learning Target: Nefrolitiaziste kalsiyum oksalat taşıını idrar mikroskopisi ile ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan sağ yan ağrısı ve bulantı nedeniyle acile başvuruyor. Ağrının dalgalar halinde kasiğa yayıldığını, yerinde durmakta zorlandığını ve idrar renginin koyulaştığını belirtiyor. Daha önce benzer bir taş düşürme öyküsü vardır.

Demografi: 46 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 135/80 mmHg | Nabız: 98/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,73

Fizik Muayene

- Hasta huzursuz ve ağrılıdır.
- Sağ kostovertebral açı hassasiyeti vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam idrar tahlili

Etiket: Tam idrar tahlili | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Mikroskopik hematüri saptandı. | Klinik anlam: Üriner taşla uyumludur. | Sonuç yorumu: Üriner taşla uyumludur. | Sonuç başlığı: Tam idrar tahlili | Sonuç özeti: Mikroskopik hematüri saptandı. | Yorum: Üriner taşla uyumludur. | Satırlar: Tam idrar tahlili / Mikroskopik hematüri saptandı. // Üriner taşla uyumludur.

Tetkik 2: İdrar mikroskopisi

Etiket: İdrar mikroskopisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Zarf şeklinde kristaller izlendi. | Klinik anlam: Taş tipinin ayırt edilmesine yardımcıdır. | Sonuç yorumu: Taş tipinin ayırt edilmesine yardımcıdır. | Sonuç başlığı: İdrar mikroskopisi | Sonuç özeti: Zarf şeklinde kristaller izlendi. | Yorum: Taş tipinin ayırt edilmesine yardımcıdır. | Satırlar: İdrar mikroskopisi / Zarf şeklinde kristaller izlendi. // Taş tipinin ayırt edilmesine yardımcıdır.

Tetkik 3: Kontrastsız üriner sistem bilgisayarlı tomografi

Etiket: Kontrastsız üriner sistem bilgisayarlı tomografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sağ distal üreterde 5 mm taş izlendi. | Klinik anlam: Taş lokalizasyonunu gösterir. | Sonuç yorumu: Taş lokalizasyonunu gösterir. | Sonuç başlığı: Kontrastsız üriner sistem bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Sağ distal üreterde 5 mm taş izlendi. | Yorum: Taş lokalizasyonunu gösterir. | Satırlar: Kontrastsız üriner sistem bilgisayarlı tomografi / Sağ distal üreterde 5 mm taş izlendi. / / Taş lokalizasyonunu gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-026 | Başlık: İdrar mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Zarf şeklinde kristaller izlendi. | Klinik anlam: Taş tipinin ayırt edilmesine yardımcıdır. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/026_026-kalsiyum-oksalat-kristalleri-idrar-mikroskopisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/026_026-kalsiyum-oksalat-kristalleri-idrar-mikroskopisi.webp | Alt text: İdrar mikroskopisi - Zarf şeklinde kristaller izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-027 | Başlık: Kontrastsız üriner sistem bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Sağ distal üreterde 5 mm taş izlendi. | Klinik anlam: Taş lokalizasyonunu gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/027_027-sag-distal-ureter-tasi-kontrastsiz-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/027_027-sag-distal-ureter-tasi-kontrastsiz-bt.webp | Alt text: Kontrastsız üriner sistem bilgisayarlı tomografi - Sağ distal üreterde 5 mm taş izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki idrar mikroskopisi bulgusu en çok hangi taş tipiyle uyumludur?

- A) Kalsiyum oksalat taşı
B) Ürik asit taşı
C) Strüvit taşı
D) Sistin taşı
E) Ksantin taşı

Doğru Cevap: Kalsiyum oksalat taşı

- A) Kalsiyum oksalat taşı: Kalsiyum oksalat taşı zarf şeklinde kristallerle ilişkili olduğu için bu idrar mikroskopisi bulgusuyla en uyumludur. Vakadaki “Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.” ve “Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Ürik asit taşı: Ürik asit taşları genellikle romboid veya iğnemi kristallerle ve asidik idrarla ilişkilidir; zarf şeklindeki kristal bulgusunu en iyi açıklamaz. Bu olguda “Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.” ve “Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kalsiyum oksalat taşı seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Strüvit taşı: Strüvit taşları enfeksiyonla ilişkili geyik boynuzu taşları ve tabut kapağı kristalleriyle düşünülür; bu olguda ateş veya enfeksiyon bulgusu yoktur. Bu olguda “Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.” ve “Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kalsiyum oksalat taşı seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Sistin taşı: Sistin taşında altıgen kristaller beklenir; zarf şeklinde kristaller sistin taşı için tipik değildir. Bu olguda “Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.” ve “Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kalsiyum oksalat taşı seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Ksantin taşı: Ksantin taşı nadir görülür ve bu Vakadaki klasik zarf kristal morfolojisiyle en iyi uyumlu seçenek değildir. Bu olguda “Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.” ve “Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kalsiyum oksalat taşı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kolik yan ağrısı olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.” ve “Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Kalsiyum oksalat taşı seçeneği öne çıkar; “İdrar mikroskopisinde zarf şeklinde kristaller görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kolik tarzda kasiğa yayılan yan ağrısı, mikroskobik hematüri ve bilgisayarlı tomografide üreter taşı nefrolitiazisi destekler. İdrar mikroskopisinde zarf şeklinde kristaller kalsiyum oksalat taşları için tipiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.”, “Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.” ve “İdrar mikroskopisinde zarf şeklinde kristaller görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kalsiyum oksalat taşı en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ağrı dalgalar halinde kasiğa yayılmaktadır.

Kanıt 2: Tam idrar tahlilinde mikroskobik hematüri saptanmıştır.

Kanıt 3: İdrar mikroskopisinde zarf şeklinde kristaller görülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanitten ayrılır.

Exam Pearl: Zarf şeklinde kristaller kalsiyum oksalat taşını; altıgen kristaller sistin taşını düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 50: v167-new-050-akut-gogus-agrisi-ve-hipotansiyon

Başlık: Akut göğüs ağrısı ve hipotansiyon

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: Kardiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: İnferior miyokard enfarktüsünde sağ ventrikül tutulumu varsa nitrat kullanımındaki riski değerlendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan baskı tarzında göğüs ağrısı ve soğuk terleme nedeniyle acile getiriliyor. Ağrının 45 dakika önce başladığı, sol kola yayılmadığı ancak bulantı eşlik ettiği öğreniliyor. Hipertansiyon ve sigara öyküsü vardır. Son saatlerde fosfodiesteraz inhibitörü kullanımı tariflemiyor.

Demografi: 61 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 85/55 mmHg | Nabız: 52/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %95% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,61

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve terlidir.
- Juguler venöz dolgunluk belirgindir; akciğer oskültasyonunda ral duyulmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: İnferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu destekler. | Sonuç yorumu: İnferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu destekler. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Yorum: İnferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu destekler. | Satırlar: Elektrokardiyografi / DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. // İnferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu destekler.

Tetkik 2: Troponin

Etiket: Troponin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Miyokard hasarını gösterir. | Sonuç yorumu: Miyokard hasarını gösterir. | Sonuç başlığı: Troponin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Miyokard hasarını gösterir. | Satırlar: Troponin / 1.8 ng/mL / <0.04 ng/mL / Miyokard hasarını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-028 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: inferior duvarla birlikte sağ ventrikül tutulumunu destekler. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/028_028-inferior-stemi-ve-v4r-tutulumu-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/028_028-inferior-stemi-ve-v4r-tutulumu-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - DII, DIII ve aVF derivasyonlarında ST elevasyonu; V4R derivasyonunda ST elevasyonu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada göğüs ağrısı için nitrat verilmesinden kaçınılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Koroner vazospazmı artırması
B) Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması
C) Trombosit agregasyonunu artırması
D) Atriyoventriküler iletimi tamamen bloke etmesi
E) Miyokard oksijen tüketimini doğrudan artırması

Doğru Cevap: Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması

A) Koroner vazospazmı artırması: Nitratlar koroner vazodilatasyon yapar ve koroner vazospazmı artırmaz; sorun bu olguda preload azalmasıdır. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması seçeneğini daha güçlü kılar.
B) Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması: Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması, V4R elevasyonu ve klinik preload bağımlılığı olan hastada nitratlardan kaçınmanın temel nedenidir. Vakadaki “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
C) Trombosit agregasyonunu artırması: Nitratlar trombosit agregasyonunu artıran ilaçlar değildir; akut karar bu mekanizma üzerinden verilmez. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Atriyoventriküler iletimi tamamen bloke etmesi: Atriyoventriküler ileti bozukluğu inferior enfarktüste görülebilir ancak nitratın temel kaçınılma nedeni tam ileti bloğu oluşturması değildir. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Miyokard oksijen tüketimini doğrudan artırması: Nitratlar genellikle preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürür; bu hastada problem sağ ventrikül dolusunun azalmasıdır. Bu olguda “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekeç / Kanıt / Core

Klinik gerekeç: Akut göğüs ağrısı ve hipotansiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.” ve “V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.” birlikte okunduğunda Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon, juguler venöz dolgunluk ve akciğerde ral olmaması preload bağımlı tabloyu düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Inferior ST elevasyonuna V4R elevasyonunun eşlik etmesi sağ ventrikül enfarktüsünü düşündürür. Sağ ventrikül enfarktüsünde kardiyak debi preloada bağımlıdır; nitrat venodilatasyonla venöz dönüşü azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.”, “V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.” ve “Hipotansiyon, juguler venöz dolgunluk ve akciğerde ral olmaması preload bağımlı tabloyu düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Sağ ventrikül preloadunu azaltarak hipotansiyonu ağırlaştırması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Elektrokardiyografide inferior derivasyonlarda ST elevasyonu vardır.

Kanıt 2: V4R derivasyonunda ST elevasyonu sağ ventrikül tutulumunu destekler.

Kanıt 3: Hipotansiyon, juguler venöz dolgunluk ve akciğerde ral olmaması preload bağımlı tabloyu düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Sağ ventrikül enfarktüsünde nitrat ve aşırı diürez preloadu düşürerek ciddi hipotansiyon yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 51: v168-new-051-omuz-hareketinde-postoperatif-gucluk

Başlık: Omuz hareketinde postoperatif güçlük

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Muayene bulgusunu anatomik yapı ve sinir-yapı ilişkisiyle eşleştirme.

Learning Target: Aksiller cerrahi sonrası kanat skapula bulgusunu ilgili sinir hasarıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ameliyat sonrası sağ kolunu yukarı kaldırmakta zorlanma ve omuz çevresinde güçsüzlük nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki hafta önce sağ meme kitlesi nedeniyle aksiller lenf nodu diseksiyonu içeren cerrahi geçirdiğini belirtiyor. Travma öyküsü yoktur ve şikâyetlerinin ameliyat sonrasında başladığını ifade ediyor.

Demografi: 48 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ omuzda aktif elevasyon kısıtlıdır.
- Hasta ellerini duvara bastırıldığında sağ skapulanın medial kenarı belirgin şekilde posteriora doğru çıkıntı yapmaktadır.
- Distal motor ve duyu muayenesi büyük ölçüde korunmuştur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma olasılığı en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus thoracodorsalis
B) Nervus intercostobrachialis
C) Nervus thoracicus longus
D) Nervus suprascapularis
E) Nervus axillaris

Doğru Cevap: Nervus thoracicus longus

A) Nervus thoracodorsalis: Nervus thoracodorsalis latissimus dorsi kasını innerve eder; hasarında kolun adduksiyon ve ekstansiyon gücü etkilenir, tipik kanat skapula beklenmez. Bu olguda “Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nervus intercostobrachialis: Nervus intercostobrachialis üst kol medial yüzünün duyusuyla ilişkilidir; skapula stabilizasyonu veya serratus anterior fonksiyonunu açıklamaz. Bu olguda “Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus thoracicus longus: Nervus thoracicus longus musculus serratus anterior kasını innerve ettiği için aksiller diseksiyon sonrası kanat skapula gelişimini en iyi açıklar. Vakadaki “Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Nervus suprascapularis: Nervus suprascapularis supraspinatus ve infraspinatus kaslarıyla ilişkilidir; skapulanın medial kenarının belirginleşmesini açıklayan temel sinir değildir. Bu olguda “Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus axillaris: Nervus axillaris deltoid kası ve lateral omuz duyusuyla ilişkilidir; humerus cerrahi boyun travması ve deltoid güçsüzlüğünde daha ön plandadır. Bu olguda “Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Omuz hareketinde postoperatif güçlük olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.” birlikte okunduğunda Nervus thoracicus longus seçeneği öne çıkar; “Kol elevasyonunda güçlük skapulanın toraks duvarına sabitlenememesiyle uyumludur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Aksiller diseksiyon sonrası duvara itme ile belirginleşen kanat skapula, musculus serratus anterior felcini düşündürür. Bu kası innerve eden nervus thoracicus longus aksiller cerrahi sırasında yüzeyel seyri nedeniyle hasarlanabilir ve skapulanın toraks duvarına sabitlenmesini bozar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.”, “Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.” ve “Kol elevasyonunda güçlük skapulanın toraks duvarına sabitlenememesiyle uyumludur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus thoracicus longus en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Şikâyetler aksiller lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Duvara bastırma sırasında skapulanın medial kenarı posteriora çıkıntı yapmaktadır.

Kanıt 3: Kol elevasyonunda güçlük skapulanın toraks duvarına sabitlenememesiyle uyumludur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Kanat skapula ve serratus anterior felci, aksiller cerrahide nervus thoracicus longus hasarını düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 52: v168-new-052-bilinc-bulanikligi-ve-hiponatremi

Başlık: Bilinç bulanıklığı ve hiponatremi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Hipotonik hiponatremide uygunsuz su tutulmasının fizyolojik mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, son iki gündür artan halsizlik, baş ağrısı ve hafif bilinç bulanıklığı nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Uzun süredir sigara içtiği, son aylarda kilo kaybı ve inatçı öksürük yaşadığı öğreniliyor. İshal, kusma veya yoğun diüretik kullanımı tariflemiyor. Günlük sıvı alımında belirgin artış yoktur.

Demografi: 66 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 125/78 mmHg | Nabız: 82/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,66

Fizik Muayene

- Hasta hafif konfüzidir.
- Mukozalar nemlidir, belirgin ortostatik hipotansiyon veya periferik ödem yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Semptomatik hiponatremi düzeyindedir. | Sonuç yorumu: Semptomatik hiponatremi düzeyindedir. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Semptomatik hiponatremi düzeyindedir. | Satırlar: Serum sodyum / 119 mmol/L / 135-145 mmol/L / Semptomatik hiponatremi düzeyindedir.

Tetkik 2: Serum osmolalitesi

Etiket: Serum osmolalitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Hipotonik tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Hipotonik tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: Serum osmolalitesi | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Hipotonik tabloyu destekler. | Satırlar: Serum osmolalitesi / 255 mOsm/kg / 275-295 mOsm/kg / Hipotonik tabloyu destekler.

Tetkik 3: İdrar osmolalitesi

Etiket: İdrar osmolalitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Uygunsuz yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hipotonik plazmaya rağmen su atılımının baskılandığını gösterir. | Sonuç yorumu: Hipotonik plazmaya rağmen su atılımının baskılandığını gösterir. | Satırlar: İdrar osmolalitesi / 620 mOsm/kg // Hipotonik plazmaya rağmen su atılımının baskılandığını gösterir.

Tetkik 4: İdrar sodyumu

Etiket: İdrar sodyumu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Efektif dolaşım hacmi azalmasına bağlı olmayan bir tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Efektif dolaşım hacmi azalmasına bağlı olmayan bir tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: İdrar sodyumu | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Efektif dolaşım hacmi azalmasına bağlı olmayan bir tabloyu destekler. | Satırlar: İdrar sodyumu / 58 mmol/L // Efektif dolaşım hacmi azalmasına bağlı olmayan bir tabloyu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hiponatreminin temel fizyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması
B) Aldosteron eksikliği nedeniyle distal tübülde sodyum geri emiliminin azalması
C) Proksimal tübülde glukoz aracılı osmotik diürezin artması
D) Henle kulpunun kalın çıkan kolunda sodyum-potasyum-klor kotransportunun inhibisyonu
E) Paratiroid hormon etkisiyle renal kalsiyum geri emiliminin artması

Doğru Cevap: Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması

A) Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması: Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimi, hipotonik plazmaya rağmen yoğun idrar ve dilüsyonel hiponatremiyi en iyi açıklar. Vakadaki “Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.” ve “Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması seçeneğini daha güçlü kılar.
B) Aldosteron eksikliği nedeniyle distal tübülde sodyum geri emiliminin azalması: Aldosteron eksikliği hiperkalemi ve hacim kaybı bulgularıyla beklenir; bu hastada idrarın uygunsuz yoğun kalması antidiüretik hormon etkisini öne çıkarır. Bu olguda “Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.” ve “Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Proksimal tübülde glukoz aracılı osmotik diürezin artması: Glukoz aracılı osmotik diürez serbest su kaybı ve hiperglisemi bağlamında düşünülür; burada hipotonik hiponatremi ve yoğun idrar vardır. Bu olguda “Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.” ve “Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Henle kulpunun kalın çıkan kolunda sodyum-potasyum-klor kotransportunun inhibisyonu: Sodyum-potasyum-klor kotransportunun inhibisyonu loop diüretik etkisini düşündürür; hastada böyle bir ilaç öyküsü ve hacim kaybı bulgusu verilmemiştir. Bu olguda “Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.” ve “Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Paratiroid hormon etkisiyle renal kalsiyum geri emiliminin artması: Paratiroid hormonun renal kalsiyum etkisi bu hastadaki hipotonik hiponatremi ve uygunsuz idrar konsantrasyonunu açıklayamaz. Bu olguda “Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.” ve “Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bilinç bulanıklığı ve hiponatremi olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.” ve “Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.” birlikte okunduğunda Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması seçeneği öne çıkar; “Mukozaların nemli olması ve ödem olmaması belirgin hipovolemi veya hipervolemi lehine değildir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipotonik hiponatremiye rağmen idrarın yoğun kalması, antidiüretik hormon etkisinin uygunsuz sürdüğünü gösterir. Antidiüretik hormon V2 reseptörleri üzerinden toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarını apikal membrana yerleştirir; böylece serbest su tutulur ve serum sodyumu dilüe olur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.”, “Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.” ve “Mukozaların nemli olması ve ödem olmaması belirgin hipovolemi veya hipervolemi lehine değildir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Toplayıcı kanalda aquaporin-2 kanallarının artmış yerleşimiyle serbest su tutulması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Serum sodyumu ve serum osmolalitesi birlikte düşüktür.

Kanıt 2: Hipotonik plazmaya rağmen idrar osmolalitesi uygunsuz şekilde yüksektir.

Kanıt 3: Mukozaların nemli olması ve ödem olmaması belirgin hipovolemi veya hipervolemi lehine değildir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Uygunsuz antidiüretik hormon etkisinde temel sorun sodyum kaybindan çok toplayıcı kanalda serbest su tutulmasıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 53: v168-new-053-yenidoganda-santral-siyanoz

Başlık: Yenidoganda santral siyanoz

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Konotrunkal kalp anomalilerinin embriyolojik temelini ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan kısa süre sonra belirginleşen morarma ve beslenme sırasında çabuk yorulma nedeniyle izleniyor. Term doğduğu, doğum ağırlığının gebelik haftasına uygun olduğu ve antenatal takiplerinde belirgin enfeksiyon öyküsü olmadığı öğreniliyor. Aile, emme sırasında morarmanın arttığını belirtiyor.

Demografi: 2 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidogan yoğun bakım

Vital Bulgular

Kan basıncı: 68/42 mmHg | Nabız: 156/dk | Solunum: 58/dk | SpO₂: %78% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 2,29 (yüksek)

Fizik Muayene

- Santral siyanoz mevcuttur.
- Prekordiyal alanda sert sistolik üfürüm duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Ventriküler septal defekt, sağ ventrikül çıkış yolu darlığı, aortun septum üzerinde yerleşimi ve sağ ventrikül hipertrofisi izlendi. | Klinik anlam: Konotrunkal septasyon kusurunu düşündüren yapısal bulgulardır. | Sonuç yorumu: Konotrunkal septasyon kusurunu düşündüren yapısal bulgulardır. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Ventriküler septal defekt, sağ ventrikül çıkış yolu darlığı, aortun septum üzerinde yerleşimi ve sağ ventrikül hipertrofisi izlendi. | Yorum: Konotrunkal septasyon kusurunu düşündüren yapısal bulgulardır. | Satırlar: Ekokardiyografi / Ventriküler septal defekt, sağ ventrikül çıkış yolu darlığı, aortun septum üzerinde yerleşimi ve sağ ventrikül hipertrofisi izlendi. // Konotrunkal septasyon kusurunu düşündüren yapısal bulgulardır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-029 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Ventriküler septal defekt, sağ ventrikül çıkış yolu darlığı, aortun septum üzerinde yerleşimi ve sağ ventrikül hipertrofisi izlendi. | Klinik anlam: Konotrunkal septasyon kusurunu düşündüren yapısal bulgulardır. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/029_029-tetraloji-fallot-ekokardiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/029_029-tetraloji-fallot-ekokardiyografi.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Ventriküler septal defekt, sağ ventrikül çıkış yolu

darlığı, aortun septum üzerinde yerleşimi ve sağ ventrikül hipertrofisi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready
Görsel 2: ID: visual-266 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Santral siyanoz mevcuttur. | Klinik anlam: Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/266_newborn_in_neonatal_care_setting.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/266_newborn_in_neonatal_care_setting.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Santral siyanoz mevcuttur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablonun gelişimsel temelinde en olası embriyolojik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma
B) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu
C) Duktus arteriosusun doğum sonrası açık kalması
D) Endokardiyal yastıkların atriyoventriküler kanal bölgesinde kaynaşamaması
E) Sinüs venozusun sağ atriyauma katılımında bozulma

Doğru Cevap: Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma

A) Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma: Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye katkısının bozulması çıkış yolu septasyon kusurunu ve bu Vakadaki kardiyak bulguları en iyi açıklar. Vakadaki “Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.” ve “Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu: Septum primumun aşırı rezorpsiyonu atriyal septal defekt tipleriyle ilişkilidir; çıkış yolu darlığı ve aortun septum üzerinde yerleşimini açıklamaz. Bu olguda “Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.” ve “Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Duktus arteriosusun doğum sonrası açık kalması: Duktus arteriosusun açık kalması ayrı bir fetal damar kalıntısı problemidir; bu Vakadaki kompleks konotrunkal yapısal bulguların temel mekanizması değildir. Bu olguda “Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.” ve “Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Endokardiyal yastıkların atriyoventriküler kanal bölgesinde kaynaşamaması: Endokardiyal yastıkların kaynaşamaması atriyoventriküler kanal defektiyle ilişkilidir; sağ ventrikül çıkış yolu darlığını birincil olarak açıklamaz. Bu olguda “Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.” ve “Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Sinüs venozusun sağ atriyauma katılımında bozulma: Sinüs venozusun sağ atriyauma katılım bozukluğu sistemik venöz dönüş anomalileriyle ilişkilidir; verilen çıkış yolu septasyon bulgularına uymaz. Bu olguda “Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.” ve “Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda santral siyanoz olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.” ve “Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma seçeneği öne çıkar; “Aortun septum üzerinde yerleşmesi çıkış yolu septasyonunun anormal olduğunu düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ventriküler septal defekt, aortun septum üzerinde yerleşimi ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte konotrunkal septasyon kusurunu düşündürür. Aortopulmoner septumun oluşumunda nöral krest hücreleri kritik rol oynar; bu hücrelerin göç veya katkısındaki bozulma konotrunkal anomalilere yol açabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.”, “Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.” ve “Aortun septum üzerinde yerleşmesi çıkış yolu septasyonunun anormal olduğunu düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç ve katkısında bozulma en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Yenidoğanda erken dönemde santral siyanoz gelişmiştir.

Kanıt 2: Ekokardiyografide ventriküler septal defekt ve sağ ventrikül çıkış yolu darlığı birlikte izlenmiştir.

Kanıt 3: Aortun septum üzerinde yerleşmesi çıkış yolu septasyonunun anormal olduğunu düşündürür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Konotrunkal kalp anomalilerinde embriyolojik anahtar nöral krest hücrelerinin aortopulmoner septuma katkısıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 54: v168-new-054-tromboz-egilimi-olan-ergen

Başlık: Tromboz eğilimi olan ergen

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Homozistinüride enzim defektini klinik ve biyokimyasal bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacak ağrısı ve görme bulanıklığı yakınmaları sonrası saptanan metabolik anormallik nedeniyle yönlendiriliyor. Ailesi, hastanın okul başarısında zorlandığını ve son yıllarda boyunun akranlarına göre belirgin uzadığını belirtiyor. Daha önce travma olmadan derin ven trombozu geçirdiği öğreniliyor.

Demografi: 13 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta uzun ve ince yapılıdır.
- Göz muayenesinde lensin aşağı-yana doğru yer değiştirdiği belirtilmiştir.
- Alt ekstremitede önceki trombozla uyumlu hafif venöz dolgunluk vardır.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma total homosistein

Etiket: Plazma total homosistein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kükürtlü amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Kükürtlü amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma total homosistein | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Kükürtlü amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Plazma total homosistein / 145 µmol/L / 5-15 µmol/L / Kükürtlü amino asit metabolizması bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: Plazma metiyonin

Etiket: Plazma metiyonin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Transsülfürasyon basamağındaki blokla uyumludur. | Sonuç yorumu: Transsülfürasyon basamağındaki blokla uyumludur. | Sonuç başlığı: Plazma metiyonin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Transsülfürasyon basamağındaki blokla uyumludur. | Satırlar: Plazma metiyonin / 82 µmol/L / 10-40 µmol/L / Transsülfürasyon basamağındaki blokla uyumludur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki temel enzim defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cystathionine beta-synthase eksikliği
B) Phenylalanine hydroxylase eksikliği
C) Homogentisate oxidase eksikliği
D) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği
E) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği

Doğru Cevap: Cystathionine beta-synthase eksikliği

A) Cystathionine beta-synthase eksikliği: Cystathionine beta-synthase eksikliği yüksek homosistein, yüksek metiyonin, lens subluksasyonu ve tromboz eğilimini birlikte açıklar. Vakadaki “Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.” ve “Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Phenylalanine hydroxylase eksikliği: Phenylalanine hydroxylase eksikliği fenilketonüriye yol açar; nörogelişimsel etkiler yapabilir ancak tromboz ve yüksek metiyonin paternini açıklamaz. Bu olguda “Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.” ve “Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Cystathionine beta-synthase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Homogentisate oxidase eksikliği: Homogentisate oxidase eksikliği alkaptonüri ile ilişkilidir ve idrarda koyulaşma ile okronozis beklenir. Bu olguda “Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.” ve “Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Cystathionine beta-synthase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği akçaağaç şurubu idrar hastalığına neden olur; bu Vakadaki lens ve tromboz bulgularına uymaz. Bu olguda “Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.” ve “Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Cystathionine beta-synthase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği klasik galaktozemiye yol açar; yenidoğan döneminde karaciğer yetmezliği, katarakt ve beslenme intoleransı beklenir. Bu olguda “Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.” ve “Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Cystathionine beta-synthase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tromboz eğilimi olan ergen olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.” ve “Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.” birlikte okunduğunda Cystathionine beta-synthase eksikliği seçeneği öne çıkar; “Homosistein ve metiyonin düzeylerinin birlikte yüksek olması transsülfürasyon basamağı blokunu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uzun ince vücut yapısı, lens subluksasyonu, tromboz eğilimi, yüksek homosistein ve yüksek metiyonin, transsülfürasyon yolunda cystathionine beta-synthase eksikliğini düşündürür. Bu defekt homosisteinin sisteine dönüşümünü bozar ve damar endoteli üzerinde pro-trombotik etki oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.”, “Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.” ve “Homosistein ve metiyonin düzeylerinin birlikte yüksek olması transsülfürasyon basamağı blokunu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Cystathionine beta-synthase eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Travma olmadan derin ven trombozu geçirmiş olması pro-trombotik metabolik durumu düşündürür.

Kanıt 2: Lensin aşağı-yana yer değiştirmesi bağ dokusu ve metabolik amino asit bozukluğu ile uyumludur.

Kanıt 3: Homosistein ve metiyonin düzeylerinin birlikte yüksek olması transsülfürasyon basamağı blokunu destekler.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Homozistinüride lens genellikle aşağı-yana sublukse olur ve tromboz eğilimi belirgindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 55: v168-new-055-yenidoganda-okuler-ve-norolojik-bulgular

Başlık: Yenidoğanda oküler ve nörolojik bulgular

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik bağlam ve mikrobiyolojik ipuçlarıyla olası etkeni belirleme.

Learning Target: Konjenital enfeksiyon triadını etken mikroorganizmayla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, göz dibi muayenesinde anormallik ve baş çevresinde artış nedeniyle ileri değerlendirmeye alınıyor. Annenin gebelik sırasında iyi pişmemiş et tükettiği ve evde kedi beslediği öğreniliyor. Doğumdan sonra bebeğin emmesinin zayıf olduğu ve zaman zaman irritabilite gösterdiği belirtiliyor.

Demografi: 10 günlük kız bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 148/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 37.4°C | Şok indeksi: 2,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebeğe baş çevresi persentil üst sınırının üzerindedir.
- Göz dibi muayenesinde retinokoroidit ile uyumlu odaklar bildirilmiştir.
- Karaciğer hafif palpe edilmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kranial ultrasonografi

Etiket: Kranial ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Ventriküler genişleme ve yaygın intrakraniyal kalsifik odaklar izlendi. | Klinik anlam: Konjenital nörolojik tutulumu destekler. | Sonuç yorumu: Konjenital nörolojik tutulumu destekler. | Sonuç başlığı: Kranial ultrasonografi | Sonuç özeti: Ventriküler genişleme ve yaygın intrakraniyal kalsifik odaklar izlendi. | Yorum: Konjenital nörolojik tutulumu destekler. | Satırlar: Kranial ultrasonografi / Ventriküler genişleme ve yaygın intrakraniyal kalsifik odaklar izlendi. // Konjenital nörolojik tutulumu destekler.

Tetkik 2: Serolojik değerlendirme

Etiket: Serolojik değerlendirme | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yenidoğanda özgül IgM pozitifliği saptandı. | Klinik anlam: İntrauterin enfeksiyon lehinedir. | Sonuç yorumu: İntrauterin enfeksiyon lehinedir. | Sonuç başlığı: Serolojik değerlendirme | Sonuç özeti: Yenidoğanda özgül IgM pozitifliği saptandı. | Yorum: İntrauterin enfeksiyon lehinedir. | Satırlar: Serolojik değerlendirme / Yenidoğanda özgül IgM pozitifliği saptandı. / İntrauterin enfeksiyon lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-030 | Başlık: Kranial ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Ventriküler genişleme ve yaygın intrakraniyal kalsifik odaklar izlendi. | Klinik anlam: Konjenital nörolojik tutulumu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsds.public.blob.vercel-storage.com/030_030-ventrikulomegali-ve-intrakraniyal-kalsifikasyon-kranial-ultrason.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsds.public.blob.vercel-storage.com/030_030-ventrikulomegali-ve-intrakraniyal-kalsifikasyon-kranial-ultrason.webp | Alt text: Kranial ultrasonografi - Ventriküler genişleme ve yaygın intrakraniyal kalsifik odaklar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cytomegalovirus
- B) Toxoplasma gondii
- C) Rubella virus
- D) Treponema pallidum
- E) Listeria monocytogenes

Doğru Cevap: Toxoplasma gondii

A) Cytomegalovirus: Cytomegalovirus konjenital enfeksiyonda periventriküler kalsifikasyon ve işitme kaybı yapabilir ancak kedi-et maruziyeti ve retinokoroidit-hidrosefali kombinasyonu bu olguda farklı bir etkeni öne çıkarır. Bu olguda “Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.” ve “Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.” ipuçları tanısallık karar açısından Toxoplasma gondii seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Toxoplasma gondii: Toxoplasma gondii gebelikte iyi pişmemiş et veya kedi temasıyla bulaşabilir ve retinokoroidit, hidrosefali ile intrakraniyal kalsifikasyon tablosunu en iyi açıklar. Vakadaki “Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.” ve “Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

C) Rubella virus: Rubella virus katarakt, kardiyak defekt ve sağırlıkla klasikleşir; verilen nöro-oküler ve maruziyet paternine en uygun seçenek değildir. Bu olguda “Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.” ve “Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.” ipuçları tanısallık karar açısından Toxoplasma gondii seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Treponema pallidum: Treponema pallidum konjenital sifiliz yapabilir ancak rinit, kemik bulguları ve hepatosplenomegali gibi farklı ipuçları beklenir. Bu olguda “Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.” ve “Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.” ipuçları tanısallık karar açısından Toxoplasma gondii seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Listeria monocytogenes: Listeria monocytogenes gebelik ve yenidoğanda sepsis-menenjit yapabilir; retinokoroidit ve hidrosefaliyle giden bu klasik tabloyu açıklamaz. Bu olguda “Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.” ve “Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.” ipuçları tanısallık karar açısından Toxoplasma gondii seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda oküler ve nörolojik bulgular olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. “Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.” ve “Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.” birlikte okunduğunda Toxoplasma gondii seçeneği öne çıkar; “Ventriküler genişleme ve intrakraniyal kalsifikasyon birlikte nörolojik tutulumu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gebelikte kedi dışkısı veya iyi pişmemiş et maruziyeti, yenidoğanda retinokoroidit, hidrosefali ve intrakraniyal kalsifikasyon birlikteliği Toxoplasma gondii enfeksiyonunu düşündürür. Özgül IgM pozitifliği enfeksiyonun yenidoğanda aktif veya intrauterin edinilmiş olduğunu destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.”, “Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.” ve “Ventriküler genişleme ve intrakraniyal kalsifikasyon birlikte nörolojik tutulumu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Toxoplasma gondii en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Gebelikte iyi pişmemiş et ve kedi teması öyküsü vardır.

Kanıt 2: Retinokoroidit yenidoğanda konjenital enfeksiyon bulgusudur.

Kanıt 3: Ventriküler genişleme ve intrakraniyal kalsifikasyon birlikte nörolojik tutulumu destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Konjenital toksoplazmozda klasik üçlü retinokoroidit, hidrosefali ve intrakraniyal kalsifikasyondur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 56: v168-new-056-agrisiz-hematuri-ve-renal-kitle

Başlık: Ağrısız hematüri ve renal kitle

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloyu morfolojik veya histopatolojik paternle ilişkilendirme.

Learning Target: Renal kitlede histolojik patern ile en olası tümörü ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tekrarlayan ağrısız makroskopik hematüri nedeniyle başvuruyor. Son aylarda kilo kaybı ve aralıklı sağ yan ağrısı tarifliyor. Uzun süreli sigara kullanımı vardır. İdrar yaparken yanma veya taş düşürme öyküsü belirtmiyor.

Demografi: 62 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 150/88 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.6°C | Şok indeksi: 0,56

Fizik Muayene

- Genel durumu iyi, hafif soluk görünümündedir.
- Sağ kostovertebral açı bölgesinde hafif hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Abdominal bilgisayarlı tomografi

Etiket: Abdominal bilgisayarlı tomografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sağ böbrek korteksinde solid, heterojen kontrastlanan kitle izlendi. | Klinik anlam: Renal parankim kaynaklı kitleyi destekler. | Sonuç yorumu: Renal parankim kaynaklı kitleyi destekler. | Sonuç başlığı: Abdominal bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Sağ böbrek korteksinde solid, heterojen kontrastlanan kitle izlendi. | Yorum: Renal parankim kaynaklı kitleyi destekler. | Satırlar: Abdominal bilgisayarlı tomografi | Sağ böbrek korteksinde solid, heterojen kontrastlanan kitle izlendi. // Renal parankim kaynaklı kitleyi destekler.

Tetkik 2: Biyopsi histopatolojisi

Etiket: Biyopsi histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: İnce damar ağı ile ayrılan yuvalar halinde dizilmiş, berrak sitoplazmalı tümör hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Tümör tipinin ayrımı için belirleyici morfolojidir. | Sonuç yorumu: Tümör tipinin ayrımı için belirleyici morfolojidir. | Sonuç başlığı: Biyopsi histopatolojisi | Sonuç özeti: İnce damar ağı ile ayrılan yuvalar halinde dizilmiş, berrak sitoplazmalı tümör hücreleri izlendi. | Yorum: Tümör tipinin ayrımı için belirleyici morfolojidir. | Satırlar: Biyopsi histopatolojisi / İnce damar ağı ile ayrılan yuvalar halinde dizilmiş, berrak sitoplazmalı tümör hücreleri izlendi. // Tümör tipinin ayrımı için belirleyici morfolojidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-031 | Başlık: Abdominal bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Sağ böbrek korteksinde solid, heterojen kontrastlanan kitle izlendi. | Klinik anlam: Renal parankim kaynaklı kitelyi destekler. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/031_031-sag-renal-kortikal-kitle-abdominal-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/031_031-sag-renal-kortikal-kitle-abdominal-bt.webp | Alt text: Abdominal bilgisayarlı tomografi - Sağ böbrek korteksinde solid, heterojen kontrastlanan kitle izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-032 | Başlık: Biyopsi histopatolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: İnce damar ağı ile ayrılan yuvalar halinde dizilmiş, berrak sitoplazmalı tümör hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Tümör tipinin ayrımı için belirleyici morfolojidir. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/032_032-clear-cell-rcc-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/032_032-clear-cell-rcc-histopatoloji.webp | Alt text: Biyopsi histopatolojisi - İnce damar ağı ile ayrılan yuvalar halinde dizilmiş, berrak sitoplazmalı tümör hücreleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ürotelyal karsinom
B) Clear cell renal cell carcinoma
C) Wilms tümörü
D) Renal onkositom
E) Anjiyomiyolipom

Doğru Cevap: Clear cell renal cell carcinoma

A) Ürotelyal karsinom: Ürotelyal karsinom renal pelvis veya mesane kaynaklı olma eğilimindedir; bu olguda kortikal kitle ve berrak hücreli morfoloji ön plandadır. Bu olguda “Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.” ve “Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.” ipuçları tanısallık açısından Clear cell renal cell carcinoma seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Clear cell renal cell carcinoma: Clear cell renal cell carcinoma ağrısız hematüri, renal kortikal kitle ve berrak sitoplazmalı hücrelerden oluşan vasküler paternle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.” ve “Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Wilms tümörü: Wilms tümörü çocukluk çağıının renal tümörüdür; bu erişkin hastanın histolojik paterni ve yaşı ile uyumlu değildir. Bu olguda “Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.” ve “Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.” ipuçları tanısallık açısından Clear cell renal cell carcinoma seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Renal onkositom: Renal onkositom genellikle eozinofilik granüler sitoplazmalı hücrelerle seyredir; berrak hücreli vasküler patern bu seçeneği geri plana iter. Bu olguda “Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.” ve “Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.” ipuçları tanısallık açısından Clear cell renal cell carcinoma seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Anjiyomiyolipom: Anjiyomiyolipom damar, düz kas ve yağ dokusu bileşenleriyle karakterizedir; bu biyopsi tanımı o morfolojiyi göstermemektedir. Bu olguda “Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.” ve “Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.” ipuçları tanısallık açısından Clear cell renal cell carcinoma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ağrısız hematüri ve renal kitle olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. “Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.” ve “Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Clear cell renal cell carcinoma seçeneği öne çıkar; “Histolojide berrak sitoplazmalı hücrelerin ince damar ağıyla ayrıldığı görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağrısız hematüri, renal kortikal solid kitle ve berrak sitoplazmalı hücrelerin ince vasküler ağıla ayrılmış yuvalar oluşturmaları clear cell renal cell carcinoma için tipiktir. Bu tümör erişkinlerde en sık renal kortikal malignitelerden biridir ve sigara öyküsü risk faktörleri arasındadır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.”, “Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.” ve “Histolojide berrak sitoplazmalı hücrelerin ince damar ağıyla ayrıldığı görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Clear cell renal cell carcinoma en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hasta ağrısız makroskopik hematüri ile başvurmuştur.

Kanıt 2: Görüntülemde böbrek korteksinde solid kontrastlanan kitle izlenmiştir.

Kanıt 3: Histolojide berrak sitoplazmalı hücrelerin ince damar ağıyla ayrıldığı görülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Berrak sitoplazmalı hücreler ve zengin ince damar ağı, clear cell renal cell carcinoma için klasik morfolojik ipucudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 57: v168-new-057-yeni-baslayan-kuru-oksuruk

Başlık: Yeni başlayan kuru öksürük

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: ACE inhibitörüne bağlı kuru öksürüğün mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, son haftalarda başlayan inatçı kuru öksürük nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık bir ay önce hipertansiyon nedeniyle yeni bir ilaç başladığını, öksürüğün balgamsız olduğunu ve ateş, burun akıntısı ya da nefes darlığı eşlik etmediğini belirtiyor. Sigara kullanmıyor.

Demografi: 55 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 128/76 mmHg | Nabız: 78/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.5°C | Şok indeksi: 0,61

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Akciğer oskültasyonu doğaldır, hişiltı veya ral duyulmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Akut infiltrasyon veya kitle lezyonu izlenmedi. | Klinik anlam: Enfeksiyon veya belirgin yapısal akciğer hastalığı lehine bulgu yoktur. | Sonuç yorumu: Enfeksiyon veya belirgin yapısal akciğer hastalığı lehine bulgu yoktur. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Akut infiltrasyon veya kitle lezyonu izlenmedi. | Yorum: Enfeksiyon veya belirgin yapısal akciğer hastalığı lehine bulgu yoktur. | Satırlar: Akciğer grafisi / Akut infiltrasyon veya kitle lezyonu izlenmedi. // Enfeksiyon veya belirgin yapısal akciğer hastalığı lehine bulgu yoktur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-033 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Akut infiltrasyon veya kitle lezyonu izlenmedi. | Klinik anlam: Enfeksiyon veya belirgin yapısal akciğer hastalığı lehine bulgu yoktur. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/033_033-normal-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/033_033-normal-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Akut infiltrasyon veya kitle lezyonu izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki ilaç ilişkili öksürüğün en olası mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beta-2 reseptör blokajına bağlı bronkokonstriksiyon
B) Histamin H1 reseptör aktivasyonuna bağlı mukozal ödem
C) Lökotrien sentezinde artışa bağlı hava yolu inflamasyonu
D) Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu
E) Muskarinik reseptör blokajına bağlı sekresyon koyulaşması

Doğru Cevap: Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu

A) Beta-2 reseptör blokajına bağlı bronkokonstriksiyon: Beta-2 reseptör blokajı bronkokonstriksiyon ve hışlıtı yapabilir; bu hastada hışlıtı yoktur ve öykü ACE inhibitörü yan etkisine daha uygundur. Bu olguda “Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.” ipuçları tanısız karar açısından Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
B) Histamin H1 reseptör aktivasyonuna bağlı mukozal ödem: Histamin H1 reseptör aktivasyonu alerjik rinit veya ürtiker bulgularıyla beklenir; izole ilaç ilişkili kuru öksürüğü en iyi açıklamaz. Bu olguda “Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.” ipuçları tanısız karar açısından Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Lökotrien sentezinde artışa bağlı hava yolu inflamasyonu: Lökotrien aracılı hava yolu inflamasyonu astım veya aspirin duyarlılığı bağlamında düşünülür; bu olguda tipik enfeksiyon veya astım bulgusu yoktur. Bu olguda “Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereksizdir.
D) Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu: Bradikinin yıkımının azalması ACE inhibitörü kullanımında kuru öksürüğün klasik mekanizmasıdır ve olgunun zamanlamasıyla uyumludur. Vakadaki “Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereksizdir.
E) Muskarinik reseptör blokajına bağlı sekresyon koyulaşması: Muskarinik reseptör blokajı ağız kuruluğu ve sekresyon koyulaşması yapabilir; ACE inhibitörüne özgü kuru öksürüğün temel mekanizması değildir. Bu olguda “Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.” ipuçları tanısız karar açısından Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yeni başlayan kuru öksürük olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.” birlikte okunduğunda Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu seçeneği öne çıkar; “Akciğer oskültasyonunun normal olması belirgin bronkospazm lehine değildir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipertansiyon tedavisi sonrası başlayan, enfeksiyon bulgusu olmayan kuru öksürük ACE inhibitörü yan etkisini düşündürür. ACE, bradikinin yıkımında da rol oynadığı için inhibisyonu bradikinin birikimine ve hava yolu irritasyonuna neden olabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.”, “Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.” ve “Akciğer oskültasyonunun normal olması belirgin bronkospazm lehine değildir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Bradikinin yıkımının azalmasına bağlı hava yolu irritasyonu en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kuru öksürük hipertansiyon için yeni ilaç başladıktan sonra ortaya çıkmıştır.

Kanıt 2: Ateş, balgam ve akciğer grafisinde infiltrasyon bulunmaması enfeksiyonu geri plana iter.

Kanıt 3: Akciğer oskültasyonunun normal olması belirgin bronkospazm lehine değildir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanitten ayrılır.

Exam Pearl: ACE inhibitörlerine bağlı kuru öksürük bradikinin birikimiyle ilişkilidir; alternatif olarak anjiyotensin reseptör blokerleri düşünülebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 58: v168-new-058-hiperglisemi-ve-asidotik-solunum

Başlık: Hiperglisemi ve asidotik solunum

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: İç Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Diyabetik ketoasidozda ilk tedavi basamağını belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, karın ağrısı, kusma ve hızlı soluma nedeniyle acile getiriliyor. Son iki gündür insülin dozlarını aksattığı, artan susama ve sık idrara çıkma yaşadığı öğreniliyor. Bugün tekrarlayan kusma ve belirgin halsizlik gelişmiştir.

Demografi: 21 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 92/58 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,35 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta dehidrate ve halsiz görünümündedir.
- Derin ve hızlı solunumu vardır, nefesinde meyvemsi koku hissedilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum glukoz

Etiket: Serum glukoz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Belirgin hiperglisemi mevcuttur. | Sonuç yorumu: Belirgin hiperglisemi mevcuttur. | Sonuç başlığı: Serum glukoz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Belirgin hiperglisemi mevcuttur. | Satırlar: Serum glukoz / 540 mg/dL / 70-140 mg/dL / Belirgin hiperglisemi mevcuttur.

Tetkik 2: Arter kan gazi

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Asidozun şiddetini gösterir. | Sonuç yorumu: Asidozun şiddetini gösterir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Asidozun şiddetini gösterir. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.12, HCO3 8 mmol/L / pH 7.35-7.45, HCO3 22-26 mmol/L / Asidozun şiddetini gösterir.

Tetkik 3: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek-normal düzeyde saptandı. | Klinik anlam: Tedavi sırasında hızlı düşebileceği için izlenmelidir. | Sonuç yorumu: Tedavi sırasında hızlı düşebileceği için izlenmelidir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek-normal düzeyde saptandı. | Yorum: Tedavi sırasında hızlı düşebileceği için izlenmelidir. | Satırlar: Serum potasyum / 5.3 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Tedavi sırasında hızlı düşebileceği için izlenmelidir.

Tetkik 4: İdrar ketonu

Etiket: İdrar ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Ketotik tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Ketotik tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: İdrar ketonu | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Ketotik tabloyu destekler. | Satırlar: İdrar ketonu / Pozitif saptandı. / / Ketotik tabloyu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-267 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Derin ve hızlı solunumu vardır, nefesinde meyvemsi koku hissedilir. | Klinik anlam: İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/267_tired_patient_in_hospital_bed.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/267_tired_patient_in_hospital_bed.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Derin ve hızlı solunumu vardır, nefesinde meyvemsi koku hissedilir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk uygulanması gereken tedavi basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz düzenli insülin infüzyonuna hemen başlanması
B) İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi
C) İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması
D) Potasyum replasmanına yüksek dozda başlanması
E) Subkutan hızlı etkili insülinle ayaktan glisemik izlem planlamak

Doğru Cevap: İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması

A) İntravenöz düzenli insülin infüzyonuna hemen başlanması: İntravenöz düzenli insülin gereklidir ancak dehidrate ve hipotansif hastada ilk adım sıvı replasmanıdır. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.” ve “Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
B) İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi: Sodyum bikarbonat yalnızca çok ağır asidoz gibi seçilmiş durumlarda düşünülür; bu olguda rutin ilk basamak değildir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.” ve “Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
C) İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması: İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı hipovolemiyi düzeltmek ve dolaşımı stabilize etmek için ilk tedavi basamağıdır. Vakadaki “İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.” ve “Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
D) Potasyum replasmanına yüksek dozda başlanması: Potasyum tedavi sırasında izlenmelidir ancak başlangıç potasyumu yüksek-normal olduğu için ilk işlem yüksek doz potasyum replasmanı değildir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.” ve “Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Subkutan hızlı etkili insülinle ayaktan glisemik izlem planlamak: Vakadaki İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir ve Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir. Bu olguda “İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.” ve “Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hiperglisemi ve asidotik solunum olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.” ve “Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.” birlikte okunduğunda İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon, taşikardi ve dehidratasyon görünümü intravasküler hacim kaybını düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada hiperglisemi, keton pozitifliği, metabolik asidoz ve dehidratasyon diyabetik ketoasidoz tablosunu gösterir. İlk basamak intravasküler hacmi düzeltmek için izotonik salin verilmesidir; insülin tedavisi sıvı başlanıp potasyum durumu güvenli şekilde değerlendirildikten sonra uygulanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.”, “Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve dehidratasyon görünümü intravasküler hacim kaybını düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İzotonik salin ile intravenöz sıvı replasmanı başlanması en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: İnsülin dozlarının aksatılması sonrası hiperglisemi ve keton pozitifliği gelişmiştir.

Kanıt 2: Derin hızlı solunum ve düşük pH metabolik asidozu gösterir.

Kanıt 3: Hipotansiyon, taşikardi ve dehidratasyon görünümü intravasküler hacim kaybını düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağına yerine geçmez.

Exam Pearl: Diyabetik ketoasidozda ilk yaklaşım sıvı replasmanıdır; insülin başlanmadan önce potasyum düzeyi mutlaka dikkate alınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 59: v168-new-059-ates-ve-sarilikla-basvuran-hasta

Başlık: Ateş ve sarılıkla başvuran hasta

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Akut kolanjitte kaynak kontrolü için uygun girişimi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ üst kadranda ağrısı, ateş ve sarılık nedeniyle acile getiriliyor. Yakınları, hastanın son bir gündür titreme ile yükselen ateşinin olduğunu ve bugün dalgalanıştığını belirtiyor. Daha önce safra kesesi taşı nedeniyle takip edildiği öğreniliyor.

Demografi: 73 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/52 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 24/dk | SpO2: %96% | Ateş: 39.1°C | Şok indeksi: 1,34 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta toksik görünümlü ve hafif konfüzedir.
- Skleralar ikteriktir.
- Sağ üst kadranda hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Total bilirubin

Etiket: Total bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kolestatik tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Kolestatik tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: Total bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kolestatik tabloyu destekler. | Satırlar: Total bilirubin / 6.8 mg/dL / 0.2-1.2 mg/dL / Kolestatik tabloyu destekler.

Tetkik 2: Alkalen fosfataz

Etiket: Alkalen fosfataz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Alkalen fosfataz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Satırlar: Alkalen fosfataz / 480 U/L / 40-130 U/L / Safra yolu obstrüksiyonunu destekler.

Tetkik 3: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Koledok çapı artmış ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak izlenmiştir. | Klinik anlam: Obstrüksiyon düzeyini düşündürür. | Sonuç yorumu: Obstrüksiyon düzeyini düşündürür. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Koledok çapı artmış ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak izlenmiştir. | Yorum: Obstrüksiyon düzeyini düşündürür. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Koledok çapı artmış ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak izlenmiştir. // Obstrüksiyon düzeyini düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-034 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Koledok çapı artmış ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak izlenmiştir. | Klinik anlam: Obstrüksiyon düzeyini düşündürür. | URL: https://iukbtlkzxcictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/034_034-dilate-koledok-ve-distal-tas-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/034_034-dilate-koledok-ve-distal-tas-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Koledok çapı artmış ve distal koledokta taş ile uyumlu ekojen odak izlenmiştir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-268 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Skleralar ikteriktir. | Klinik anlam: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj | URL: https://iukbtlkzxcictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/268_close_up_of_aged_finely_textured_face.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/268_close_up_of_aged_finely_textured_face.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Skleralar ikteriktir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: İntravenöz sıvı ve geniş spektrumlu antibiyotik başlanmış olan bu hastada en uygun kaynak kontrolü yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Elektif laparoskopik kolesistektomi planlanması
B) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj
C) Ayaktan oral antibiyotik ve poliklinik kontrolü
D) Tanısal manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi için tedavinin ertelenmesi
E) Analjezik tedavi ve klinik izlem

Doğru Cevap: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj

A) Elektif laparoskopik kolesistektomi planlanması: Elektif laparoskopik kolesistektomi daha sonraki taş kaynaklı olayları önlemek için planlanabilir ancak akut obstrükte safra yolu enfeksiyonunda ilk kaynak kontrolü değildir. Bu olguda “Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj: Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj obstrüksiyonu açarak enfekte safra yolunda gerekli kaynak kontrolünü sağlar. Vakadaki “Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleştirilir.

C) Ayaktan oral antibiyotik ve poliklinik kontrolü: Ayaktan oral antibiyotik hipotansiyon ve konfüzyonu olan ağır enfeksiyon tablosunda yetersiz ve güvensizdir. Bu olguda “Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Tanısal manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi için tedavinin ertelenmesi: Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi tanısal bilgi verebilir ancak bu olguda obstrüksiyon ve sepsis bulguları varken drenajı geciktirmemelidir. Bu olguda “Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Analjezik tedavi ve klinik izlem: Vakadaki Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür ve Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir. Bu olguda “Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve sarılıkla başvuran hasta olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.” ve “Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.” birlikte okunduğunda Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide koledok genişlemesi ve distal taş bulgusu obstrüksiyonu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, sağ üst kadranda ağrısı, sarılık, hipotansiyon ve konfüzyon obstrüksiyona bağlı ağır safra yolu enfeksiyonunu düşündürür. Sıvı ve antibiyotik başlanması gerekir; ancak obstrükte safra yolunun boşaltılması için acil endoskopik biliyer drenaj kaynak kontrolünü sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.”, “Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.” ve “Ultrasonografide koledok genişlemesi ve distal taş bulgusu obstrüksiyonu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi ile biliyer drenaj en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık birlikte safra yolu enfeksiyonunu düşündürür.

Kanıt 2: Hipotansiyon ve konfüzyon ağır sistemik etkilenmeyi gösterir.

Kanıt 3: Ultrasonografide koledok genişlemesi ve distal taş bulgusu obstrüksiyonu destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ağır akut kolanjitte antibiyotik tek başına yeterli değildir; obstrüksiyon varsa erken biliyer drenaj kaynak kontrolüdür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 60: v168-new-060-agiz-yaralari-ve-gevsek-buller

Başlık: Ağız yaraları ve gevşek büller

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar / Dermatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloyu morfolojik veya histopatolojik paternle ilişkilendirme.

Learning Target: Pemfigus vulgariste klinik ve histolojik bulgularla hedef antijeni ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ağrılı ağız yaraları ve gövdede kolay açılan su dolu kabarcıklar nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki aydır ağız içinde iyileşmeyen ağrılı erozyonları olduğunu, son haftalarda gövde ve saçlı deride kolay patlayan kabarcıklar geliştiğini belirtiyor. Yeni ilaç kullanımı veya yanık öyküsü yoktur.

Demografi: 52 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Oral mukozada yaygın erozyonlar vardır.
- Gövdede ince duvarlı, gevşek büller ve erode alanlar izlenir.
- Lezyon çevresindeki sağlam görünen deriye hafif basınç uygulandığında epidermal ayrılma gelişmektedir.
- Hemodinamik instabilite düşündürülen belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Deri biyopsisi

Etiket: Deri biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Suprabazal akantoliz ve intraepidermal bül oluşumu izlendi. | Klinik anlam: Epidermal hücreler arası adezyon kaybını gösterir. | Sonuç yorumu: Epidermal hücreler arası adezyon kaybını gösterir. | Sonuç başlığı: Deri biyopsisi | Sonuç özeti: Suprabazal akantoliz ve intraepidermal bül oluşumu izlendi. | Yorum: Epidermal hücreler arası adezyon kaybını gösterir. | Satırlar: Deri biyopsisi / Suprabazal akantoliz ve intraepidermal bül oluşumu izlendi. // Epidermal hücreler arası adezyon kaybını gösterir.

Tetkik 2: Direkt immünfloresan inceleme

Etiket: Direkt immünfloresan inceleme | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Epidermiste hücreler arası ağ şeklinde IgG birikimi saptandı. | Klinik anlam: Desmozomal hedeflere karşı otoantikor varlığını destekler. | Sonuç yorumu: Desmozomal hedeflere karşı otoantikor varlığını destekler. | Sonuç başlığı: Direkt immünfloresan inceleme | Sonuç özeti: Epidermiste hücreler arası ağ şeklinde IgG birikimi saptandı. | Yorum: Desmozomal hedeflere karşı otoantikor varlığını destekler. | Satırlar: Direkt immünfloresan inceleme / Epidermiste hücreler arası ağ şeklinde IgG birikimi saptandı. // Desmozomal hedeflere karşı otoantikor varlığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-035 | Başlık: Deri biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Suprabazal akantoliz ve intraepidermal bül oluşumu izlendi. | Klinik anlam: Epidermal hücreler arası adezyon kaybını gösterir. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/035_035-suprabazal-akantoliz-deri-biyopsisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/035_035-suprabazal-akantoliz-deri-biyopsisi.webp | Alt text: Deri biyopsisi - Suprabazal akantoliz ve intraepidermal bül oluşumu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-036 | Başlık: Direkt immünfloresan inceleme | Modalite: microscopy | Bulgu: Epidermiste hücreler arası ağ şeklinde IgG birikimi saptandı. | Klinik anlam: Desmozomal hedeflere karşı otoantikor varlığını destekler. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/036_036-hucreler-arasi-igg-birikimi-direkt-immunfloresan.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/036_036-hucreler-arasi-igg-birikimi-direkt-immunfloresan.webp | Alt text: Direkt immünfloresan inceleme - Epidermiste hücreler arası ağ şeklinde IgG birikimi saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 3: ID: visual-269 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Gövdede ince duvarlı, gevşek büller ve erode alanlar izlenir. ; Lezyon çevresindeki sağlam görünen deriye hafif basınç uygulandığında epidermal ayrılma gelişmektedir. | Klinik anlam: Desmoglein 3 | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/269_severe_dermatologic_condition_on_torso.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/269_severe_dermatologic_condition_on_torso.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Gövdede ince duvarlı, gevşek büller ve erode alanlar izlenir. ; Lezyon çevresindeki sağlam görünen deriye hafif basınç uygulandığında epidermal ayrılma gelişmektedir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta hedef alınan temel adezyon proteini aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Desmoglein 3
B) BP180 kollajen
C) Tip VII kollajen
D) Laminin 332
E) Integrin alfa-6 beta-4

Doğru Cevap: Desmoglein 3

- A) Desmoglein 3: Desmoglein 3, mukozal tutulumlu belirgin olan pemfigus vulgariste hedeflenen temel desmozomal adezyon proteini. Vakadaki "Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir." ve "Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) BP180 kollajen: BP180 kollajen bülöz pemfigoidde hemidesmozomal hedeflerden biridir; bu hastalıkta büller genellikle gergindir ve subepidermal yerleşim beklenir. Bu olguda "Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir." ve "Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür." ipuçları klinik karar açısından Desmoglein 3 seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Tip VII kollajen: Tip VII kollajen epidermolizis bülloza acquisita ile ilişkilidir; suprabazal akantoliz ve hücreler arası IgG paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda "Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir." ve "Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür." ipuçları klinik karar açısından Desmoglein 3 seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Laminin 332: Laminin 332 mukoz membran pemfigoidinde hedeflenebilir; bu Vakadaki intraepidermal akantolitik patern bu seçeneği desteklemez. Bu olguda "Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir." ve "Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür." ipuçları klinik karar açısından Desmoglein 3 seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Integrin alfa-6 beta-4: Integrin alfa-6 beta-4 hemidesmozomal bağlantılarla ilişkilidir; pemfigus vulgaristeki desmozomal hücreler arası adezyon kaybını açıklamaz. Bu olguda "Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir." ve "Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür." ipuçları klinik karar açısından Desmoglein 3 seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ağız yaraları ve gevşek büller olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir." ve "Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür." birlikte okunduğunda Desmoglein 3 seçeneği öne çıkar; "Biyopside suprabazal akantoliz ve hücreler arası IgG birikimi gösterilmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağrılı oral erozyonlar, gevşek büller, pozitif epidermal ayrılma bulgusu, suprabazal akantoliz ve hücreler arası IgG birikimi pemfigus vulgaris ile uyumludur. Bu hastalıkta otoantikorlar desmozomal adezyon proteinlerinden özellikle desmoglein 3'e yönelir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir.", "Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür." ve "Biyopside suprabazal akantoliz ve hücreler arası IgG birikimi gösterilmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Desmoglein 3 en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Ağrılı oral mukozal erozyonlar erken ve belirgin bulgu olarak verilmiştir.

Kanıt 2: Gevşek büller ve basınçla epidermal ayrılma epidermis içi adezyon kaybını düşündürür.

Kanıt 3: Biyopside suprabazal akantoliz ve hücreler arası IgG birikimi gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Pemfigus vulgariste hedef desmozomal desmogleinlerdir; bül intraepidermaldir ve oral mukoza sık tutulur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 61: v169-new-061-uzamis-ates-ve-mukokutanoz-bulgular

Başlık: Uzamış ateş ve mukokutanöz bulgular

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Kawasaki hastalığında komplikasyon gelişimini önleyen temel tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, beş gündür düşmeyen ateş ve döküntü nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi ateşin antibiyotik kullanmasına rağmen devam ettiğini, son günlerde gözlerde kızarıklık, dudaklarda çatlama ve el-ayaklarda şişlik geliştiğini belirtiyor. Öksürük, belirgin burun akıntısı veya idrar yakınması tariflenmiyor.

Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 39.2°C | Şok indeksi: 1,28 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk huzursuz görünümündedir.
- Bilateral eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış kırmızı dudaklar, çilek dili, gövdede polimorf döküntü ve el-ayaklarda ödem vardır.
- Servikal bölgede tek taraflı yaklaşık 2 cm lenf nodu palpe edilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Sistemik inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 92 mg/L / <5 mg/L / Sistemik inflamasyonu destekler.

Tetkik 2: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Trombosit sayısı yüksek saptandı. | Klinik anlam: Subakut inflamatuvar süreçle uyumludur. | Sonuç yorumu: Subakut inflamatuvar süreçle uyumludur. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Trombosit sayısı yüksek saptandı. | Yorum: Subakut inflamatuvar süreçle uyumludur. | Satırlar: Tam kan sayımı / 620000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Subakut inflamatuvar süreçle uyumludur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-270 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Bilateral eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış kırmızı dudaklar, çilek dili, gövdede polimorf döküntü ve el-ayaklarda ödem vardır. | Klinik anlam: İntravenöz immün globulin ve aspirin | URL: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/270_pediatric_patient_with_rash_in_clinic.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/270_pediatric_patient_with_rash_in_clinic.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Bilateral eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış kırmızı dudaklar, çilek dili, gövdede polimorf döküntü ve el-ayaklarda ödem vardır. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada koroner arter komplikasyon riskini azaltmak için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yüksek doz amoksisilin-klavulanat
B) İntravenöz immün globulin ve aspirin
C) Antipiretik tedaviyle klinik izlemi sürdürmek
D) Oral asiklovir tedavisi
E) Acil tonsillektomi

Doğru Cevap: İntravenöz immün globulin ve aspirin

- A) Yüksek doz amoksisilin-klavulanat: Yüksek doz amoksisilin-klavulanat bakteriyel enfeksiyon tedavisidir; bu olguda antibiyotiğe yanıtız uzamış ateş ve mukokutanöz bulgular vaskülit düşündürür. Bu olguda “Ateş beş gündür devam etmektedir.” ve “Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immün globulin ve aspirin seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) İntravenöz immün globulin ve aspirin: İntravenöz immün globulin ve aspirin, Kawasaki hastalığında koroner arter komplikasyon riskini azaltan uygun tedavi yaklaşımıdır. Vakadaki “Ateş beş gündür devam etmektedir.” ve “Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- C) Antipiretik tedaviyle klinik izlemi sürdürmek: Vakadaki Ateş beş gündür devam etmektedir ve Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir. Bu olguda “Ateş beş gündür devam etmektedir.” ve “Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immün globulin ve aspirin seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Oral asiklovir tedavisi: Oral asiklovir herpes virüs enfeksiyonlarında kullanılır; bu hastadaki yaygın vaskülitik mukokutanöz tabloyu tedavi etmez. Bu olguda “Ateş beş gündür devam etmektedir.” ve “Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immün globulin ve aspirin seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Acil tonsillektomi: Acil tonsillektomi eksüdatif tonsillit veya obstrüktif sorunlar için düşünülebilir; bu Vakadaki sistemik vaskülit tablosunda yeri yoktur. Bu olguda “Ateş beş gündür devam etmektedir.” ve “Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immün globulin ve aspirin seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzamış ateş ve mukokutanöz bulgular olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ateş beş gündür devam etmektedir.” ve “Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.” birlikte okunduğunda İntravenöz immün globulin ve aspirin seçeneği öne çıkar; “El-ayak ödemi, polimorf döküntü ve servikal lenfadenopati aynı inflamatuvar tabloyu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Beş günden uzun ateş, eksüdasız konjonktivit, oral mukoza değişiklikleri, polimorf döküntü, ekstremitte ödemi ve servikal lenfadenopati Kawasaki hastalığını düşündürür. Koroner arter anevrizması riskini azaltan temel tedavi erken dönemde intravenöz immün globulin verilmesi ve aspirin tedavisidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ateş beş gündür devam etmektedir.”, “Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.” ve “El-ayak ödemi, polimorf döküntü ve servikal lenfadenopati aynı inflamatuvar tabloyu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı

desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz immün globulin ve aspirin en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ateş beş gündür devam etmektedir.

Kanıt 2: Eksüdasız konjonktival hiperemi, çatlamış dudaklar ve çilek dili mukokutanöz tutulumu gösterir.

Kanıt 3: El-ayak ödemi, polimorf döküntü ve servikal lenfadenopati aynı inflamatuvar tabloyu destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Kawasaki hastalığında en önemli hedef koroner arter anevrizmasını önlemektir; tedavide intravenöz immün globulin geciktirilmemelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 62: v169-new-062-gebelikte-hipertansiyon-ve-norolojik-yakinma

Başlık: Gebelikte hipertansiyon ve nörolojik yakınma

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Ağır preeklampside nöbet profilaksisi için uygun ilacı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, baş ağrısı ve görme bulanıklığı nedeniyle acil başvuruda değerlendiriliyor. Son bir haftadır el ve yüzde şişlik fark ettiğini, bugün şiddetli baş ağrısı ve ışık çakmaları başladığını belirtiyor. Daha önce hipertansiyon tanısı yoktur. Fetal hareketleri hissettiğini ifade ediyor.

Demografi: 31 yaşında gebe hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 160/100 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,60

Fizik Muayene

- Hasta huzursuz ve fotofobiktir.
- Pretibial ödem mevcuttur.
- Sağ üst kadranda hafif hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar protein/kreatinin oranı

Etiket: İdrar protein/kreatinin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Proteinüriyi destekler. | Sonuç yorumu: Proteinüriyi destekler. | Sonuç başlığı: İdrar protein/kreatinin oranı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Proteinüriyi destekler. | Satırlar: İdrar protein/kreatinin oranı / 0.9 mg/mg / <0.3 mg/mg / Proteinüriyi destekler.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Ağır hastalık bulgusu olarak değerlendirilir. | Sonuç yorumu: Ağır hastalık bulgusu olarak değerlendirilir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Ağır hastalık bulgusu olarak değerlendirilir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 98000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Ağır hastalık bulgusu olarak değerlendirilir.

Tetkik 3: Aspartat aminotransferaz

Etiket: Aspartat aminotransferaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Karaciğer etkilenebilirliğini düşündürür. | Sonuç yorumu: Karaciğer etkilenebilirliğini düşündürür. | Sonuç başlığı: Aspartat aminotransferaz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Karaciğer etkilenebilirliğini düşündürür. | Satırlar: Aspartat aminotransferaz / 86 U/L / <35 U/L / Karaciğer etkilenebilirliğini düşündürür.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada eklampitik nöbet profilaksisi için en uygun ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Magnezyum sülfat
B) Furosemid
C) Warfarin
D) Oral benzodiazepinle kontrol tedavisi olarak nöbet profilaksisi planlamak
E) Metilergonovin

Doğru Cevap: Magnezyum sülfat

- A) Magnezyum sülfat: Magnezyum sülfat ağır preeklampside eklampitik nöbet profilaksisi için birinci tercih ilaçtır. Vakadaki “Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Furosemid: Furosemid rutin nöbet profilaksisi sağlamaz; pulmoner ödem gibi özel durumlarda destekleyici olarak düşünülebilir. Bu olguda “Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Warfarin: Warfarin gebelikte teratojenite riski taşıyan antikoagülandır ve preeklampitik nöbetleri önlemez. Bu olguda “Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Oral benzodiazepinle kontrol tedavisi olarak nöbet profilaksisi planlamak: Vakadaki Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır ve Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir. Bu olguda “Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Metilergonovin: Metilergonovin uterotonik etkilidir ve hipertansiyonu artırabileceği için bu klinik bağlamda uygun değildir. Bu olguda “Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte hipertansiyon ve nörolojik yakınma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.” birlikte okunduğunda Magnezyum sülfat seçeneği öne çıkar; “Proteinüri, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği sistemik etkilenebilirlik destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gebeliğin 20. haftasından sonra gelişen ağır hipertansiyon, proteinüri, baş ağrısı, görme bulguları, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği ağır preeklampsi ile uyumludur. Bu tabloda eklampitik nöbetleri önlemek için tercih edilen ilaç magnezyum sülfattır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Gebeliğin 34.

haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.”, “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.” ve “Proteinüri, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği sistemik etkilenimi destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Magnezyum sülfat en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Gebeliğin 34. haftasında yeni başlangıçlı ağır hipertansiyon vardır.

Kanıt 2: Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özellikleri gösterir.

Kanıt 3: Proteinüri, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği sistemik etkilenimi destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ağır preeklampside nöbet profilaksisinin temel ilacı magnezyum sülfattır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 63: v169-new-063-trombositopeni-ve-norolojik-bulgu

Başlık: Trombositopeni ve nörolojik bulgu

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: İç Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Trombotik trombositopenik purpurada ilk tedavi yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, burun kanaması, halsizlik ve geçici konuşma bozukluğu atakları nedeniyle acile başvuruyor. Son üç gündür kolay morarma ve baş ağrısı olduğunu, bugün kısa süreli dalgınlık ve kelime bulma güçlüğü yaşadığını belirtiyor. Yeni ilaç kullanımı veya bilinen karaciğer hastalığı yoktur.

Demografi: 38 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 138/84 mmHg | Nabız: 98/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 37.6°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Ciltte yaygın peteşiler ve ekimozlar vardır.
- Hasta değerlendirme sırasında oryantendir ancak yakınları dalgınlık atakları tariflemektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Ciddi trombositopeni mevcuttur. | Sonuç yorumu: Ciddi trombositopeni mevcuttur. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Ciddi trombositopeni mevcuttur. | Satırlar: Trombosit sayısı / 18000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ | Ciddi trombositopeni mevcuttur.

Tetkik 2: Hemogloblin

Etiket: Hemogloblin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Anemi mevcuttur. | Sonuç yorumu: Anemi mevcuttur. | Sonuç başlığı: Hemogloblin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Anemi mevcuttur. | Satırlar: Hemogloblin / 8.6 g/dL / 12-16 g/dL / Anemi mevcuttur.

Tetkik 3: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik hemolizi destekler. | Sonuç yorumu: Mikroanjyopatik hemolizi destekler. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Şistositler izlendi. | Yorum: Mikroanjyopatik hemolizi destekler. | Satırlar: Periferik yayma / Şistositler izlendi. / / Mikroanjyopatik hemolizi destekler.

Tetkik 4: Kreatinin

Etiket: Kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Organ etkilenimini düşündürür. | Sonuç yorumu: Organ etkilenimini düşündürür. | Sonuç başlığı: Kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Organ etkilenimini düşündürür. | Satırlar: Kreatinin / 1.8 mg/dL / 0.6-1.1 mg/dL / Organ etkilenimini düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-037 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik hemolizi destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/037_037-sistositler-periferik-yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/037_037-sistositler-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Şistositler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-271 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Ciltte yaygın peteşiler ve ekimozlar vardır. | Klinik anlam: Acil plazma değişimi | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/271_petechial_and_purpuric_rash_on_legs.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/271_petechial_and_purpuric_rash_on_legs.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Ciltte yaygın peteşiler ve ekimozlar vardır. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hayat kurtarıcı ilk tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trombosit transfüzyonu
- B) Acil plazma değişimi
- C) Oral demir tedavisi
- D) İntravenöz sıvı tedavisi
- E) Elektif splenektomi planlanması

Doğru Cevap: Acil plazma değişimi

A) Trombosit transfüzyonu: Trombosit transfüzyonu aktif yaşamı tehdit eden kanama yoksa TTP’de mikrotrombozu artırabileceği için rutin ilk tedavi değildir. Bu olguda “Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjyopatik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Acil plazma değişimi: Acil plazma değişimi TTP’de otoantikörleri uzaklaştırıp ADAMTS13 desteği sağladığı için hayat kurtarıcı ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjyopatik hemolizi destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

C) Oral demir tedavisi: Oral demir tedavisi kronik demir eksikliği anemisinde kullanılır; mikroanjyopatik hemoliz ve trombositopeniyi tedavi etmez. Bu olguda “Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjyopatik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) İntravenöz sıvı tedavisi: Vakadaki Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir ve Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjyopatik hemolizi destekler. Bu olguda “Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjyopatik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Elektif splenektomi planlanması: Elektif splenektomi kronik seçilmiş hematolojik durumlarda düşünülebilir; akut TTP tablosunda ilk hayat kurtarıcı tedavi değildir. Bu olguda “Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjyopatik hemolizi destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil plazma değişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Trombositopeni ve nörolojik bulgu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.” ve “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi destekler.” birlikte okunduğunda Acil plazma değişimi seçeneği öne çıkar; “Geçici nörolojik belirtiler ve kreatinin yüksekliği sistemik mikrotromboz etkilenimini düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Trombositopeni, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, nörolojik belirtiler ve böbrek etkilenimi trombotik trombositopenik purpurayı düşündürür. Tedavide gecikmeden plazma değişimi yapılmalıdır; bu yaklaşım patojenik otoantikorları uzaklaştırır ve ADAMTS13 aktivitesini destekleyen plazma sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.”, “Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi destekler.” ve “Geçici nörolojik belirtiler ve kreatinin yüksekliği sistemik mikrotromboz etkilenimini düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil plazma değişimi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ciddi trombositopeni ve peteşiler kanama eğilimini göstermektedir.

Kanıt 2: Periferik yaymada şistosit görülmesi mikroanjiyopatik hemolizi destekler.

Kanıt 3: Geçici nörolojik belirtiler ve kreatinin yüksekliği sistemik mikrotromboz etkilenimini düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: TTP şüphesinde ADAMTS13 sonucu beklenmeden acil plazma değişimi başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 64: v169-new-064-antibiyotik-sonrasi-ishal

Başlık: Antibiyotik sonrası ishal

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik bağlam ve mikrobiyolojik ipuçlarıyla olası etkeni belirleme.

Learning Target: Antibiyotik sonrası psödomembranöz kolitte etken ve toksin aracılı patogenezi tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, son iki gündür başlayan sulu ishal ve karın ağrısı nedeniyle değerlendiriliyor. Bir hafta önce pnömoni nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi aldığı öğreniliyor. Günde sekiz-on kez sulu dışkılama, kramp tarzı karın ağrısı ve halsizlik tarifliyor. Kanlı dışkılama belirgin değildir.

Demografi: 67 yaşında kadın hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 105/68 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 38.1°C | Şok indeksi: 0,99 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta halsiz ve dehidrate görünümündedir.
- Batında yaygın hassasiyet vardır, defans yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lökositoz saptandı. | Klinik anlam: Enflamatuvar enfeksiyöz süreci destekler. | Sonuç yorumu: Enflamatuvar enfeksiyöz süreci destekler. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lökositoz saptandı. | Yorum: Enflamatuvar enfeksiyöz süreci destekler. | Satırlar: Tam kan sayımı / 17800 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Enflamatuvar enfeksiyöz süreci destekler.

Tetkik 2: Dışkıda toksin testi

Etiket: Dışkıda toksin testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksin A/B pozitif saptandı. | Klinik anlam: Toksin aracılı kolit lehinedir. | Sonuç yorumu: Toksin aracılı kolit lehinedir. | Sonuç başlığı: Dışkıda toksin testi | Sonuç özeti: Toksin A/B pozitif saptandı. | Yorum: Toksin aracılı kolit lehinedir. | Satırlar: Dışkıda toksin testi / Toksin A/B pozitif saptandı. // Toksin aracılı kolit lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Clostridioides difficile
- B) Vibrio cholerae
- C) Salmonella enterica
- D) Entamoeba histolytica
- E) Giardia lamblia

Doğru Cevap: Clostridioides difficile

A) Clostridioides difficile: Clostridioides difficile antibiyotik sonrası flora baskılanmasıyla çoğalır ve toksin A/B aracılığıyla bu kolit tablosunu oluşturur. Vakadaki “Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Vibrio cholerae: Vibrio cholerae piriñ suyu görünümünde bol sulu ishal yapabilir ancak antibiyotik sonrası toksin A/B pozitifliği ile uyumlu değildir. Bu olguda “Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tanısallık karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Salmonella enterica: Salmonella enterica gıda kaynaklı gastroenterit yapabilir; bu olguda zamanlama ve toksin testi antibiyotik ilişkili koliti destekler. Bu olguda “Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tanısallık karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Entamoeba histolytica: Entamoeba histolytica kanlı mukuslu dizanteri ve karaciğer apsesiyle ilişkilidir; verilen toksin A/B sonucu bu seçenekle uyumlu değildir. Bu olguda “Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tanısallık karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Giardia lamblia: Giardia lamblia yağlı, kötü kokulu ishal ve malabsorpsiyon yapar; antibiyotik sonrası inflamatuvar kolit paternini açıklamaz. Bu olguda “Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ipuçları tanısallık karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antibiyotik sonrası ishal olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.” ve “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” birlikte okunduğunda Clostridioides difficile seçeneği öne çıkar; “Dışkıda toksin A/B pozitifliği toksin aracılı etkeni göstermektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Geniş spektrumlu antibiyotik sonrası gelişen ateş, lökositoz, sulu ishal ve dışkıda toksin A/B pozitifliği Clostridioides difficile kolitini düşündürür. Bu etken normal bağırsak florasının baskılanması sonrası çoğalır ve toksinleri aracılığıyla mukozal inflamasyon ile psödomembranöz kolite yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.”, “Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.” ve “Dışkıda toksin A/B pozitifliği toksin aracılı etkeni göstermektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Clostridioides difficile en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Şikâyetler geniş spektrumlu antibiyotik kullanımından sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Ateş, karın hassasiyeti ve lökositoz inflamatuvar koliti destekler.

Kanıt 3: Dışkıda toksin A/B pozitifliği toksin aracılı etkeni göstermektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Antibiyotik sonrası sulu ishal ve toksin A/B pozitifliği Clostridioides difficile için klasik ipucudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 65: v169-new-065-anestezi-sirasinda-ani-kriz

Başlık: Anestezi sırasında ani kriz

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Malign hipertermide dantrolenin etki mekanizmasını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, genel anestezi indüksiyonundan kısa süre sonra ani kas rijiditesi ve hızlı vücut ısısı artışı nedeniyle acil müdahale gerektiriyor. Preoperatif değerlendirmede bilinen kronik hastalığı olmadığı öğrenilmiştir. Ailede anestezi sırasında açıklanamayan ölüm öyküsü olduğu sonradan belirtilmiştir.

Demografi: 26 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 142/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,51 (yüksek)

Fizik Muayene

- Genel anestezi altında yaygın kas rijiditesi gelişmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kreatin kinaz

Etiket: Serum kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kas yıkımını destekler. | Sonuç yorumu: Kas yıkımını destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatin kinaz | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Kas yıkımını destekler. | Satırlar: Serum kreatin kinaz / 18500 U/L / 30-200 U/L / Kas yıkımını destekler.

Tetkik 2: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik ve respiratuvar asidoz saptandı. | Klinik anlam: Hipermetabolik krizin sistemik etkisini gösterir. | Sonuç yorumu: Hipermetabolik krizin sistemik etkisini gösterir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik ve respiratuvar asidoz saptandı. | Yorum: Hipermetabolik krizin sistemik etkisini gösterir. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.18 / pH 7.35-7.45 / Hipermetabolik krizin sistemik etkisini gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tabloda kullanılan dantrolenin temel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması
- B) Asetilkolinesterazı inhibe ederek nöromüsküler iletimi artırması
- C) Gama-aminobütirik asit A reseptörünü aktive ederek sedasyon sağlaması
- D) Dopamin D2 reseptörlerini bloke ederek otonom hiperaktiviteyi azaltması
- E) Voltaj kapılı sodyum kanallarını bloke ederek aksiyon potansiyelini durdurması

Doğru Cevap: Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması

A) Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması: Ryanodin reseptörü üzerinden kalsiyum salınımını azaltmak dantrolenin malign hipertermideki temel ve ayırt edici mekanizmasıdır. Vakadaki “Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.” ve “Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir.” iuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Asetilkolinesterazı inhibe ederek nöromüsküler iletimi artırması: Asetilkolinesteraz inhibisyonu nöromüsküler iletimi artırır ve bu hiperkontraksiyon tablosunu düzeltmek için uygun mekanizma değildir. Bu olguda “Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.” ve “Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir.” iuçları mekanizma bilgisi açısından Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Gama-aminobütirik asit A reseptörünü aktive ederek sedasyon sağlaması: Gama-aminobütirik asit A reseptör aktivasyonu sedasyon sağlar ancak iskelet kasındaki patolojik kalsiyum salınımını doğrudan durdurmaz. Bu olguda “Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.” ve “Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir.” iuçları mekanizma bilgisi açısından Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Dopamin D2 reseptörlerini bloke ederek otonom hiperaktiviteyi azaltması: Dopamin D2 reseptör blokajı antipsikotik etkiyle ilişkilidir ve malign hiperterminin temel kas kalsiyum mekanizmasını hedeflemez. Bu olguda “Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.” ve “Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir.” iuçları mekanizma bilgisi açısından Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Voltaj kapılı sodyum kanallarını bloke ederek aksiyon potansiyelini durdurması: Voltaj kapılı sodyum kanal blokajı lokal anestezik etkiyi açıklar; dantrolenin malign hipertermideki etkisi bu kanal üzerinden değildir. Bu olguda “Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.” ve “Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir.” iuçları mekanizma bilgisi açısından Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Anestezi sırasında ani kriz olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.” ve “Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir.” birlikte okunduğunda Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması seçeneği öne çıkar; “Kreatin kinaz yüksekliği kas yıkımını destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Genel anestezi sırasında gelişen kas rijiditesi, hiperkapni, hipertermi, asidoz ve kreatin kinaz yüksekliği malign hipertermiyi düşündürür. Dantrolen, iskelet kasında ryanodin reseptörü aracılı sarkoplazmik retikulum kalsiyum salınımını azaltarak kas kontraksiyonu ve hipermetabolizmayı kontrol eder. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.", "Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir." ve "Kreatin kinaz yüksekliği kas yıkımını destekler." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ryanodin reseptörü üzerinden sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını azaltması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Genel anestezi sonrasında yaygın kas rijiditesi başlamıştır.

Kanıt 2: Hızlı hipertermi ve end-tidal karbondioksit artışı hipermetabolik krizi gösterir.

Kanıt 3: Kreatin kinaz yüksekliği kas yıkımını destekler.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Malign hipertermide antidot dantrolendir; hedef iskelet kasında ryanodin reseptörü aracılı kalsiyum salınımıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 66: v169-new-066-eriskinde-nefrotik-tablo

Başlık: Erişkinde nefrotik tablo

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloyu morfolojik veya histopatolojik paternle ilişkilendirme.

Learning Target: Nefrotik sendromda membranöz nefropati paternini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacaklarda şişlik ve köpüklü idrar nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki aydır giderek artan ayak bileği ödemi olduğunu ve idrarının belirgin köpüklendiğini belirtiyor. Diyabet öyküsü yoktur. Son dönemde belirgin enfeksiyon veya yeni ilaç kullanımı tariflemiyor.

Demografi: 46 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 138/86 mmHg | Nabız: 82/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,59

Fizik Muayene

- Bilateral pretibial gode bırakan ödem vardır.
- Akciğer oskültasyonunda belirgin ral yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: 24 saatlik idrar protein düzeyi

Etiket: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Klinik anlam: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç yorumu: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç başlığı: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Sonuç özeti: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Yorum: Nefrotik sendromu destekler. | Satırlar: 24 saatlik idrar protein düzeyi / 6.2 g/gün / <0.15 g/gün / Nefrotik sendromu destekler.

Tetkik 2: Serum albümin

Etiket: Serum albümin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Protein kaybına bağlı hipoalbüminemi mevcuttur. | Sonuç yorumu: Protein kaybına bağlı hipoalbüminemi mevcuttur. | Sonuç başlığı: Serum albümin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Protein kaybına bağlı hipoalbüminemi mevcuttur. | Satırlar: Serum albümin / 2.3 g/dL / 3.5-5.0 g/dL / Protein kaybına bağlı hipoalbüminemi mevcuttur.

Tetkik 3: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi

Etiket: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal elektron-dens immün kompleks birikimleri izlendi. | Klinik anlam: Nefrotik sendrom etiyolojisini ayırt ettirir. | Sonuç yorumu: Nefrotik sendrom etiyolojisini ayırt ettirir. | Sonuç başlığı: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Sonuç özeti: Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal elektron-dens immün kompleks birikimleri izlendi. | Yorum: Nefrotik sendrom etiyolojisini ayırt ettirir. | Satırlar: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi / Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal elektron-dens immün kompleks birikimleri izlendi. / / Nefrotik sendrom etiyolojisini ayırt ettirir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-038 | Başlık: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal elektron-dens immün kompleks birikimleri izlendi. | Klinik anlam: Nefrotik sendrom etiyolojisini ayırt ettirir. | URL: https://iukbtlkzxtctqdsds.public.blob.vercel-storage.com/038_038-subepitelyal-elektron-dens-birikim-em.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtctqdsds.public.blob.vercel-storage.com/038_038-subepitelyal-elektron-dens-birikim-em.webp | Alt text: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi - Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal elektron-dens immün kompleks birikimleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastanın böbrek biyopsisinde ışık mikroskobunda beklenen tipik morfolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kresent oluşumu ve Bowman aralığında fibrin birikimi
- B) Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü
- C) Mezangial IgA birikimine bağlı mezangial proliferasyon
- D) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma
- E) Nodüler glomerüloskleroz ve Kimmelstiel-Wilson nodülleri

Doğru Cevap: Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü

A) Kresent oluşumu ve Bowman aralığında fibrin birikimi: Kresent oluşumu hızlı ilerleyen glomerülofrit paternini düşündürür; bu olguda nefrotik tablo ve subepitelyal birikim ön plandadır. Bu olguda "Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır." ve "Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur." ipuçları tanısal karar açısından Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü: Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü subepitelyal immün kompleks birikimleriyle seyreden membranöz nefropatiye uyar. Vakadaki "Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır." ve "Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Mezangial IgA birikimine bağlı mezangial proliferasyon: Mezangial IgA birikimine bağlı mezangial proliferasyon genellikle hematuriyi ataklarıyla seyreden IgA nefropatisini düşündürür. Bu olguda "Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır." ve "Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur." ipuçları tanısal karar açısından Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma: Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma amiloidoz bulgusudur; verilen elektron mikroskopi paterniyle doğrudan uyumlu değildir. Bu olguda "Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır." ve "Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur." ipuçları tanısal karar açısından Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nodüler glomerüloskleroz ve Kimmelstiel-Wilson nodülleri: Kimmelstiel-Wilson nodülleri diyabetik nefropati için tipiktir; hastada diyabet öyküsü verilmemiştir ve subepitelyal immün kompleks paterni farklıdır. Bu olguda "Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır." ve "Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur." ipuçları tanısal karar açısından Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erişkinde nefrotik tablo olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır.” ve “Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur.” birlikte okunduğunda Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü seçeneği öne çıkar; “Elektron mikroskopide subepitelyal immün kompleks birikimleri gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erişkinde nefrotik düzey proteinüri, hipoalbüminemi ve subepitelyal immün kompleks birikimleri membranöz nefropatiyi düşündürür. Bu hastalıkta glomerüler bazal membran immün kompleksler arasında yeni membran materyali oluşturur ve ışık mikroskopunda spike and dome görünümü beklenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır.”, “Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur.” ve “Elektron mikroskopide subepitelyal immün kompleks birikimleri gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Glomerüler bazal membranda spike and dome görünümü en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbüminemi vardır.

Kanıt 2: Ödem protein kaybıyla uyumlu klinik bulgudur.

Kanıt 3: Elektron mikroskopide subepitelyal immün kompleks birikimleri gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanitten ayrılır.

Exam Pearl: Membranöz nefropatide subepitelyal birikimler ve spike and dome görünümü klasik nefrotik sendrom ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 67: v169-new-067-kalca-cerrahisi-sonrasi-yurume-bozuklugu

Başlık: Kalça cerrahisi sonrası yürüme bozukluğu

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Muayene bulgusunu anatomik yapı ve sinir-yapı ilişkisiyle eşleştirme.

Learning Target: Trendelenburg bulgusunu superior gluteal sinir hasarıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yürürken pelvisinin dengesizleşmesi ve merdiven çıkmada zorlanma nedeniyle değerlendiriliyor. Üç hafta önce sağ total kalça protezi ameliyatı geçirdiğini, ameliyattan sonra sağ bacak üzerine basarken gövdesini dengelemek zorunda kaldığını belirtiyor. Travma veya yeni düşme öyküsü yoktur.

Demografi: 64 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta sağ bacağı üzerinde tek ayak durduğunda sol pelvis aşağı düşmektedir.
- Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.
- Uyluk ön ve arka kas gücü belirgin korunmuştur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma olasılığı en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus gluteus superior
- B) Nervus gluteus inferior
- C) Nervus obturatorius
- D) Nervus femoralis
- E) Nervus ischiadicus

Doğru Cevap: Nervus gluteus superior

- A) Nervus gluteus superior: Nervus gluteus superior gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını innerve ettiği için kalça abduksiyon kaybı ve Trendelenburg bulgusunu en iyi açıklar. Vakadaki “Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.” ve “Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Nervus gluteus inferior: Nervus gluteus inferior gluteus maximus kasını innerve eder; hasarında kalça ekstansiyon güçsüzlüğü beklenir, abduktör yetmezliği baskın değildir. Bu olguda “Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.” ve “Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nervus obturatorius: Nervus obturatorius uyluk adduktorlarını innerve eder; karşı pelvisin düşmesiyle karakterize abduktör stabilite kusurunu açıklamaz. Bu olguda “Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.” ve “Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nervus femoralis: Nervus femoralis quadriceps kası ve diz ekstansiyonu ile ilişkilidir; bu olguda uyluk ön kas gücü korunmuştur. Bu olguda “Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.” ve “Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus ischiadicus: Nervus ischiadicus arka uyluk ve bacak-ayak motor fonksiyonlarıyla ilişkilidir; izole kalça abduksiyon kaybı için en uygun sinir değildir. Bu olguda “Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.” ve “Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.” ipuçları tanısai karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kalça cerrahisi sonrası yürüme bozukluğu olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.” ve “Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.” birlikte okunduğunda Nervus gluteus superior seçeneği öne çıkar; “Yakın zamanda kalça cerrahisi geçirilmiş olması bölgesel sinir hasarı riskini artırır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tek ayak duruşunda karşı pelvisin düşmesi Trendelenburg bulgusudur ve stance tarafındaki kalça abduktörlerinin yetersizliğini gösterir. Musculus gluteus medius ve musculus gluteus minimus kaslarını nervus gluteus superior innerve eder; bu sinirin hasarı kalça stabilitesini bozar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.”, “Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.” ve “Yakın zamanda kalça cerrahisi geçirilmiş olması bölgesel sinir hasarı riskini artırır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus gluteus superior en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Sağ bacak üzerinde dururken karşı pelvis aşağı düşmektedir.

Kanıt 2: Sağ kalça abduksiyon gücü azalmıştır.

Kanıt 3: Yakın zamanda kalça cerrahisi geçirilmiş olması bölgesel sinir hasarı riskini artırır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Trendelenburg bulgusunda hasarlı taraf stance tarafıdır ve temel sinir nervus gluteus superior olarak düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 68: v169-new-068-kronik-dispne-ve-hava-hapsi

Başlık: Kronik dispne ve hava hapsi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Amfizemde hava hapsinin temel mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, giderek artan efor dispnesi ve uzun süredir devam eden öksürük nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık 35 paket-yıl sigara öyküsü vardır. Son yıllarda merdiven çıkarken nefes darlığının arttığını, kilo kaybettiğini ve balgamının az olduğunu belirtiyor.

Demografi: 59 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %93% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Hasta zayıf görünümündür.
- Göğüs ön-arka çapı artmıştır.
- Solunum sesleri bilateral azalmıştır ve ekspiryum uzamıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Solunum fonksiyon testi

Etiket: Solunum fonksiyon testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: FEV1/FVC oranı azalmış, rezidüel volüm artmış saptandı. | Klinik anlam: Obstrüktif hava akımı kısıtlılığı ve hava hapsini destekler. | Sonuç yorumu: Obstrüktif hava akımı kısıtlılığı ve hava hapsini destekler. | Sonuç başlığı: Solunum fonksiyon testi | Sonuç özeti: FEV1/FVC oranı azalmış, rezidüel volüm artmış saptandı. | Yorum: Obstrüktif hava akımı kısıtlılığı ve hava hapsini destekler. | Satırlar: Solunum fonksiyon testi / FEV1/FVC oranı azalmış, rezidüel volüm artmış saptandı. // Obstrüktif hava akımı kısıtlılığı ve hava hapsini destekler.

Tetkik 2: Toraks bilgisayarlı tomografi

Etiket: Toraks bilgisayarlı tomografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Bilateral hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu ile uyumlu alanlar izlendi. | Klinik anlam: Parankimal elastik yapı kaybını düşündürür. | Sonuç yorumu: Parankimal elastik yapı kaybını düşündürür. | Sonuç başlığı: Toraks bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Bilateral hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu ile uyumlu alanlar izlendi. | Yorum: Parankimal elastik yapı kaybını düşündürür. | Satırlar: Toraks bilgisayarlı tomografi / Bilateral hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu ile uyumlu alanlar izlendi. // Parankimal elastik yapı kaybını düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-039 | Başlık: Toraks bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Bilateral hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu ile uyumlu alanlar izlendi. | Klinik anlam: Parankimal elastik yapı kaybını düşündürür. | URL: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/039_039-amfizematik-hiperinflasyon-toraks-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/039_039-amfizematik-hiperinflasyon-toraks-bt.webp | Alt text: Toraks bilgisayarlı tomografi - Bilateral hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu ile uyumlu alanlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hava hapsinin temel fizyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması
- B) Pulmoner surfaktan üretiminin azalmasına bağlı alveoler kollaps
- C) Plevral boşlukta hava birikimine bağlı akciğer kompresyonu
- D) Alveol-kapiller membranda immün kompleks birikimine bağlı difüzyon blokajı
- E) Solunum merkezinin karbondioksit duyarlılığının tamamen kaybolması

Doğru Cevap: Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması

- A) Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması: Elastik geri çekilimin azalması ekspirasyonda küçük hava yolu kollapsına yol açarak amfizemdeki hava hapsini en iyi açıklar. Vakadaki “Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.” ve “Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Pulmoner surfaktan üretiminin azalmasına bağlı alveoler kollaps: Surfaktan azalması yenidoğan solunum sıkıntısı veya alveoler kollapsa ilişkilidir; bu olguda hiperinflasyon ve obstrüksiyon ön plandadır. Bu olguda “Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.” ve “Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Plevral boşlukta hava birikimine bağlı akciğer kompresyonu: Plevral boşlukta hava birikimi pnömotoraks mekanizmasıdır; kronik obstrüktif hava hapsini açıklamaz. Bu olguda “Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.” ve “Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Alveol-kapiller membranda immün kompleks birikimine bağlı difüzyon blokajı: Alveol-kapiller membranda immün kompleks birikimi interstiyel veya vasküler süreçleri düşündürür; burada temel sorun hava yolu dinamikleridir. Bu olguda “Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.” ve “Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Solunum merkezinin karbondioksit duyarlılığının tamamen kaybolması: Solunum merkezinin karbondioksit duyarlılığının tamamen kaybolması bu hastadaki mekanik hava hapsinin ana nedeni değildir. Bu olguda “Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.” ve “Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik dispne ve hava hapsi olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.” ve “Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.” birlikte okunduğunda Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması seçeneği öne çıkar; “Tomografide hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sigara öyküsü, hiperinflasyon, azalmış solunum sesleri, düşük FEV1/FVC ve artmış rezidüel volüm amfizem ağırlıklı obstrüktif hastalığı düşündürür. Alveoler duvar destrüksiyonu elastik geri çekilimi azaltır; ekspirasyonda küçük hava yolları kollabe olur ve hava hapsi gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı,

“Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.”, “Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.” ve “Tomografide hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akciğer elastik geri çekiliminin azalması ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kollabe olması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Uzun süreli sigara öyküsü amfizem için önemli risk oluşturur.

Kanıt 2: Solunum fonksiyon testinde FEV1/FVC azalmış ve rezidüel volüm artmıştır.

Kanıt 3: Tomografide hiperinflasyon ve alveoler duvar destrüksiyonu izlenmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Amfizemde temel fizyolojik sorun elastik recoil kaybı, dinamik hava yolu kollapsı ve rezidüel volüm artışıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 69: v169-new-069-protein-alimi-sonrasi-ensefalopati

Başlık: Protein alımı sonrası ensefalopati

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Ornitin transkarbamilaz eksikliğinde biyokimyasal patern ve kalıtımı tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme sonrası kusma, letarji ve solunum düzensizliği nedeniyle yatırılıyor. Doğumdan sonraki ilk gün iyi olduğu, protein içeren beslenme arttıkça emmesinin bozulduğu ve giderek letarjik hale geldiği öğreniliyor. Ailede erkek bebek kaybı öyküsü olduğu belirtiliyor.

Demografi: 3 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan yoğun bakım

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 164/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 2,34 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve hipotoniktir.
- Belirgin hepatosplenomegali yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma amonyak

Etiket: Plazma amonyak | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır hiperammonemi gösterir. | Sonuç yorumu: Ağır hiperammonemi gösterir. | Sonuç başlığı: Plazma amonyak | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Ağır hiperammonemi gösterir. | Satırlar: Plazma amonyak / 780 µmol/L / <80 µmol/L / Ağır hiperammonemi gösterir.

Tetkik 2: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Hipoglisemi ön planda değildir. | Sonuç yorumu: Hipoglisemi ön planda değildir. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Hipoglisemi ön planda değildir. | Satırlar: Kan glukozu / 86 mg/dL / 70-100 mg/dL / Hipoglisemi ön planda değildir.

Tetkik 3: İdrar orotik asit

Etiket: İdrar orotik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Karbamoil fosfatın pirimidin sentezine yönlendiği düşündürür. | Sonuç yorumu: Karbamoil fosfatın pirimidin sentezine yönlendiği düşündürür. | Sonuç başlığı: İdrar orotik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Karbamoil fosfatın pirimidin sentezine yönlendiği düşündürür. | Satırlar: İdrar orotik asit / Yüksek saptandı. // Karbamoil fosfatın pirimidin sentezine yönlendiği düşündürür.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki metabolik tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
C) Glukoz-6-fosfataz eksikliği
D) Propiyonil-CoA karboksilaz eksikliği
E) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği

Doğru Cevap: Ornitin transkarbamilaz eksikliği

A) Ornitin transkarbamilaz eksikliği: Ornitin transkarbamilaz eksikliği ağır hiperammonemi ve yüksek orotik asit paternini birlikte açıklar. Vakadaki “Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.” ve “Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilalanin birikimiyle seyreder; yenidoğanda akut ağır hiperammonemi ve orotik asit yüksekliğini açıklamaz. Bu olguda “Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.” ve “Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.” ipuçları tanısal karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği açık hipoglisemisi ve laktik asidoza öne çıkar; bu olguda glukoz normaldir ve amonyak belirgin yüksektir. Bu olguda “Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.” ve “Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.” ipuçları tanısal karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Propiyonil-CoA karboksilaz eksikliği: Propiyonil-CoA karboksilaz eksikliği organik asidemi yapabilir; yüksek orotik asitli üre döngüsü paternini en iyi açıklamaz. Bu olguda “Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.” ve “Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.” ipuçları tanısal karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği Lesch-Nyhan sendromuyla ilişkilidir; yenidoğan hiperammonemisi ve protein sonrası ensefalopati için uygun değildir. Bu olguda “Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.” ve “Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.” ipuçları tanısal karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Protein alımı sonrası ensefalopati olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.” ve “Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.” birlikte okunduğunda Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneği öne çıkar; “İdrar orotik asit yüksekliği karbamoil fosfatın alternatif yola kaydığını düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erkek yenidoğanda protein alımı sonrası ağır hiperammonemi, normal glukoz ve yüksek idrar orotik asit ornitin transkarbamilaz eksikliğini düşündürür. Bu üre döngüsü defektinde karbamoil fosfat mitokondride birikir ve pirimidin sentez yoluna kayarak orotik asidi artırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.”, “Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.” ve “İdrar orotik asit yüksekliği karbamoil

fosfatın alternatif yola kaydığını düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ornitin transkarbamilaz eksikliği en tutarlı yanittır.

Kanıt 1: Semptomlar protein içeren beslenme arttıktan sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Plazma amonyak düzeyi ağır derecede yüksektir.

Kanıt 3: İdrar orotik asit yüksekliği karbamoil fosfatın alternatif yola kaydığını düşündürür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Erkek yenidoğanda hiperammonemi ve yüksek orotik asit, X’e bağlı ornitin transkarbamilaz eksikliğini düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 70: v169-new-070-ani-goz-agrisi-ve-gorme-bulanikligi

Başlık: Ani göz ağrısı ve görme bulanıklığı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar / Göz Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Akut aç kapanması glokomunda ilk acil medikal yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ gözde ani başlayan şiddetli ağrı, görme bulanıklığı ve bulantı nedeniyle acile başvuruyor. Ağrının karanlık bir ortamda film izledikten sonra başladığını, ışıkların etrafında renkli halkalar gördüğünü belirtiyor. Daha önce benzer ama kısa süren ataklar yaşamıştır.

Demografi: 62 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 142/84 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,62

Fizik Muayene

- Sağ gözde belirgin konjonktival hiperemi, korneal bulanıklık ve orta derecede dilate, ışığa zayıf yanıt veren pupil vardır.
- Palpasyonla sağ göz küresi serttir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Göz içi basıncı ölçümü

Etiket: Göz içi basıncı ölçümü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sağ gözde belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Acil basınç düşürme gereksinimini gösterir. | Sonuç yorumu: Acil basınç düşürme gereksinimini gösterir. | Sonuç başlığı: Göz içi basıncı ölçümü | Sonuç özeti: Sağ gözde belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Acil basınç düşürme gereksinimini gösterir. | Satırlar: Göz içi basıncı ölçümü / 54 mmHg / 10-21 mmHg / Acil basınç düşürme gereksinimini gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk acil medikal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması
B) Rutin gözlük numarası ölçümü yapılması
C) Oral antihistaminik verilmesi
D) Elektif katarakt cerrahisi için randevu verilmesi
E) Acil intravitreal antibiyotik uygulanması

Doğru Cevap: Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması

A) Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması: Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi, görmeyi tehdit eden akut basınç yüksekliğinde ilk acil medikal yaklaşımdır. Vakadaki “Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.” ve “Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Rutin gözlük numarası ölçümü yapılması: Rutin gözlük numarası ölçümü refraksiyon kusurları için uygundur; bu olguda akut ağrılı yüksek göz içi basıncı vardır. Bu olguda “Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.” ve “Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Oral antihistaminik verilmesi: Vakadaki Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür ve Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır. Bu olguda “Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.” ve “Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Elektif katarakt cerrahisi için randevu verilmesi: Elektif katarakt cerrahisi akut krizde ilk yaklaşım değildir; görme kaybını önlemek için basınç acilen düşürülmelidir. Bu olguda “Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.” ve “Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Acil intravitreal antibiyotik uygulanması: Acil intravitreal antibiyotik endoftalmi şüphesinde düşünülür; bu olguda temel sorun enfeksiyon değil aç kapanmasına bağlı basınç artışıdır. Bu olguda “Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.” ve “Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani göz ağrısı ve görme bulanıklığı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.” ve “Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması seçeneği öne çıkar; “Göz içi basıncı sağ gözde belirgin yüksek ölçülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ani göz ağrısı, bulanık görme, halolar, bulantı, mid-dilate pupil, korneal bulanıklık ve çok yüksek göz içi basıncı akut aç kapanması glokomunu düşündürür. İlk acil yaklaşım göz içi basıncını hızla düşürmeye yönelik topikal ve sistemik medikal tedavidir; kesin önleme için daha sonra lazer iridotomi planlanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.”, “Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.” ve “Göz içi basıncı sağ gözde belirgin yüksek ölçülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Topikal ve sistemik göz içi basıncı düşürücü tedavi başlanması en tutarlı yanittır.

Kanıt 1: Ani şiddetli göz ağrısı, halolar ve bulantı akut basınç artışı düşündürür.

Kanıt 2: Korneal bulanıklık ve ışığa zayıf yanıt veren orta dilate pupil saptanmıştır.

Kanıt 3: Göz içi basıncı sağ gözde belirgin yüksek ölçülmüştür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Akut açığı kapanması glokomunda önce göz içi basıncı acil düşürülür, ardından kalıcı çözüm için lazer iridotomi düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 71: v172-new-071-cocukta-agrisiz-alt-gastrointestinal-kanama

Başlık: Çocukta ağrısız alt gastrointestinal kanama

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik ve objektif verileri temel patofizyolojik mekanizmayla ilişkilendirme.

Learning Target: Meckel divertikülünün embriyolojik kökenini klinik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, tekrarlayan ağrısız koyu kırmızı rektal kanama nedeniyle başvuruyor. Ailesi son iki ayda birkaç kez dışkıyla birlikte kan geldiğini, kanama sırasında karın ağrısı veya ateş olmadığını belirtiyor. Kabızlık, anal fissür öyküsü veya travma tariflenmiyor.

Demografi: 5 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk cerrahisi polikliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 96/60 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,08 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk genel durumu iyi, hafif soluk görünümündedir.
- Batın yumuşaktır, defans ve rebound yoktur.
- Perianal bölgede fissür izlenmez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemogloblin

Etiket: Hemogloblin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Tekrarlayan kan kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Tekrarlayan kan kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Hemogloblin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Tekrarlayan kan kaybını destekler. | Satırlar: Hemogloblin / 9.8 g/dL / 11.5-14.5 g/dL / Tekrarlayan kan kaybını destekler.

Tetkik 2: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi

Etiket: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi | Tip: xray | Alt tip: Direkt grafi | Özet: Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu fokal tutulum izlendi. | Klinik anlam: Kanama odağının mukozal özelliğini gösterir. | Sonuç yorumu: Kanama odağının mukozal özelliğini gösterir. | Sonuç başlığı: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi | Sonuç özeti: Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu fokal tutulum izlendi. | Yorum: Kanama odağının mukozal özelliğini gösterir. | Satırlar: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi / Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu fokal tutulum izlendi. // Kanama odağının mukozal özelliğini gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-040 | Başlık: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu fokal tutulum izlendi. | Klinik anlam: Kanama odağının mukozal özelliğini gösterir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/040_040-meckel-sintigrafisi-ektopik-gastrik-mukoza.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/040_040-meckel-sintigrafisi-ektopik-gastrik-mukoza.webp | Alt text: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi - Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu fokal tutulum izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki tablonun embriyolojik temelinde en olası mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ürakuş kalıntısının açık kalması
B) Nöral tüpün kaudal nöropor kapanma kusuru
C) Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması
D) Müller kanalının füzyon kusuru
E) Midgut rotasyonunun tamamen durması

Doğru Cevap: Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması

A) Ürakuş kalıntısının açık kalması: Ürakuş kalıntısının açık kalması umbilikustan idrar gelmesi gibi üriner bulgular yapar; ağrısız gastrointestinal kanamayı açıklamaz. Bu olguda “Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.” ve “Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.” ipuçları tanısız karar açısından Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nöral tüpün kaudal nöropor kapanma kusuru: Kaudal nöropor kapanma kusuru spina bifida gibi nöral tüp defektleriyle ilişkilidir; ektopik gastrik mukozalı ileal lezyonu açıklamaz. Bu olguda “Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.” ve “Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.” ipuçları tanısız karar açısından Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması: Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması Meckel divertikülünün embriyolojik temelidir ve bu Vakadaki ağrısız kanama ile uyumludur. Vakadaki “Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.” ve “Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Müller kanalının füzyon kusuru: Müller kanal füzyon kusuru uterus anomalileriyle ilişkilidir; erkek çocukta gastrointestinal kanama tablosunu açıklamaz. Bu olguda “Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.” ve “Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.” ipuçları tanısız karar açısından Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Midgut rotasyonunun tamamen durması: Midgut rotasyon kusurları volvulus ve obstrüksiyon bulguları oluşturabilir; ektopik gastrik mukozalı kanama odağını en iyi açıklamaz. Bu olguda “Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.” ve “Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.” ipuçları tanısız karar açısından Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Çocukta ağrısız alt gastrointestinal kanama olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.” ve “Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.” birlikte okunduğunda Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması seçeneği öne çıkar; “Sintigrafide sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza tutulumu gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çocukta ağrısız tekrarlayan alt gastrointestinal kanama ve sintigrafide ektopik gastrik mukoza tutulumu Meckel divertikülünü düşündürür. Meckel divertikülü, embriyonik dönemde orta barsak ile yolk sac arasındaki omfalomezenterik kanalın tam obliterasyonunun gerçekleşmemesi sonucu oluşur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.”, “Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.” ve “Sintigrafide sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza tutulumu gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanama tekrarlayıcı ve ağrısızdır.

Kanıt 2: Perianal fissür veya akut batın bulgusu yoktur.

Kanıt 3: Sintigrafide sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza tutulumu gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Meckel divertikülü omfalomezenterik kanal kalıntısıdır ve çocukta ağrısız alt gastrointestinal kanamayla sınavda sık sorulur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 72: v172-new-072-direncli-hipertansiyon-ve-kas-gucsuzlugu

Başlık: Dirençli hipertansiyon ve kas güçsüzlüğü

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik ve objektif verileri temel patofizyolojik mekanizmayla ilişkilendirme.

Learning Target: Primer hiperaldosteronizmde renal elektrolit ve asit-baz değişikliklerini mekanizma düzeyinde açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kontrol altına alınamayan hipertansiyon ve aralıklı kas güçsüzlüğü nedeniyle başvuruyor. Son bir yıldır üç farklı antihipertansif kullanmasına rağmen kan basıncının yüksek seyrettiğini belirtiyor. Zaman zaman bacaklarda güçsüzlük ve çarpıntı yaşadığını ifade ediyor. Kusma, ishal veya diüretik kötüye kullanımı tariflemiyor.

Demografi: 44 yaşında kadın hasta | Setting: Endokrinoloji polikliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 166/98 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,53

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Kas gücü muayenesinde proksimal alt ekstremitelerde hafif güçsüzlük vardır.
- Periferik ödem belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Mineralokortikoid fazlalığıyla uyumlu olabilir. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid fazlalığıyla uyumlu olabilir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Mineralokortikoid fazlalığıyla uyumlu olabilir. | Satırlar: Serum potasyum / 2.9 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Mineralokortikoid fazlalığıyla uyumlu olabilir.

Tetkik 2: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik alkaloz saptandı. | Klinik anlam: Hidrojen iyonu kaybını düşündürür. | Sonuç yorumu: Hidrojen iyonu kaybını düşündürür. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik alkaloz saptandı. | Yorum: Hidrojen iyonu kaybını düşündürür. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.49, HCO₃ 32 mmol/L / pH 7.35-7.45, HCO₃ 22-26 mmol/L / Hidrojen iyonu kaybını düşündürür.

Tetkik 3: Plazma aldosteron/renin oranı

Etiket: Plazma aldosteron/renin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Primer mineralokortikoid fazlalığı lehinedir. | Sonuç yorumu: Primer mineralokortikoid fazlalığı lehinedir. | Sonuç başlığı: Plazma aldosteron/renin oranı | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Primer mineralokortikoid fazlalığı lehinedir. | Satırlar: Plazma aldosteron/renin oranı / Belirgin yüksek saptandı. / Primer mineralokortikoid fazlalığı lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hipokalemi ve metabolik alkalozun temel renal mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Proksimal tübülde bikarbonat geri emiliminin azalması
- B) Henle kulpunun inen kolunda su geçirgenliğinin azalması
- C) Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması
- D) Glomerüler filtrasyon basıncının azalmasına bağlı sodyum atılımının artması
- E) Distal tübülde paratiroid hormon aracılı kalsiyum geri emiliminin azalması

Doğru Cevap: Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması

A) Proksimal tübülde bikarbonat geri emiliminin azalması: Proksimal tübülde bikarbonat geri emiliminin azalması metabolik asidoza eğilim oluşturur; bu Vakadaki alkalozu açıklamaz. Bu olguda “Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Henle kulpunun inen kolunda su geçirgenliğinin azalması: Henle kulpunun inen kolunda su geçirgenliği değişikliği konsantrasyon mekanizmasını etkiler ancak hipokalemi metabolik alkalozun temel nedeni değildir. Bu olguda “Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması: Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimi artarken potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması bu Vakadaki hipokalemi ve metabolik alkalozu doğrudan açıklar. Vakadaki “Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

D) Glomerüler filtrasyon basıncının azalmasına bağlı sodyum atılımının artması: Glomerüler filtrasyon basıncının azalması dirençli hipertansiyon, hipokalemi ve aldosteron fazlalığı paternini açıklamaz. Bu olguda “Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Distal tübülde paratiroid hormon aracılı kalsiyum geri emiliminin azalması: Paratiroid hormon aracılı kalsiyum geri emilimi bu hastadaki potasyum ve asit-baz bozukluğunun temel mekanizması değildir. Bu olguda “Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Dirençli hipertansiyon ve kas güçsüzlüğü olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” birlikte okunduğunda Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması seçeneği öne çıkar; “Metabolik alkaloz ve yüksek aldosteron/renin oranı aynı renal mekanizmayı destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Primer aldosteron fazlalığında aldosteron, distal nefron ve toplayıcı kanalda epitel sodyum kanalı aktivitesini artırır. Sodyum geri emilimi lümeni daha negatif hale getirir; bu durum potasyum sekresyonunu artırır ve alfa-interkale hücrelerden hidrojen iyonu atılımını destekleyerek hipokalemi ile metabolik alkalozu neden olur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.”, “Serum potasyumu düşüktür.” ve “Metabolik alkaloz ve yüksek aldosteron/renin oranı aynı renal mekanizmayı destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimiyle birlikte potasyum ve hidrojen sekresyonunun artması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Dirençli hipertansiyon mineralokortikoid fazlalığını düşündürmektedir.

Kanıt 2: Serum potasyumu düşüktür.

Kanıt 3: Metabolik alkaloz ve yüksek aldosteron/renin oranı aynı renal mekanizmayı destekler.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Aldosteron fazlalığında hipertansiyon, hipokalemi ve metabolik alkaloz distal nefronda sodyum tutulumu ile potasyum-hidrojen atılımı artışından kaynaklanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 73: v172-new-073-kirli-yara-sonrası-kas-spazmlari

Başlık: Kirli yara sonrası kas spazmları

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik ve objektif verileri temel patofizyolojik mekanizmayla ilişkilendirme.

Learning Target: Tetanoz toksininin sinaptik inhibitör nörotransmitter salınımı üzerindeki etkisini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, çene kilitlenmesi ve ağrılı kasılmalar nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 10 gün önce bahçede çalışırken paslı metal parçasıyla ayağından yaralandığını, yara için sağlık kuruluşuna başvurmadığını belirtiyor. Aşı öyküsünü hatırlamamaktadır. Son iki gündür yutkunma güçlüğü ve sırt kaslarında ağrılı kasılmalar gelişmiştir.

Demografi: 37 yaşında erkek hasta | Setting: Acil serviste

Vital Bulgular

Kan basıncı: 148/92 mmHg | Nabız: 116/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 0,78

Fizik Muayene

- Hasta uyanık ve ajitedir.
- Trismus, risus sardonius görünümü ve uyarıyla artan yaygın kas spazmları izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yara değerlendirmesi

Etiket: Yara değerlendirmesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Ayak tabanında kirli, derin ve kenarları düzensiz iyileşen yara izlendi. | Klinik anlam: Anaerob sporlu bakteri için uygun giriş kapısıdır. | Sonuç yorumu: Anaerob sporlu bakteri için uygun giriş kapısıdır. | Sonuç başlığı: Yara değerlendirmesi | Sonuç özeti: Ayak tabanında kirli, derin ve kenarları düzensiz iyileşen yara izlendi. | Yorum: Anaerob sporlu bakteri için uygun giriş kapısıdır. | Satırlar: Yara değerlendirmesi / Ayak tabanında kirli, derin ve kenarları düzensiz iyileşen yara izlendi. // Anaerob sporlu bakteri için uygun giriş kapısıdır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki kas spazmlarının temel toksin mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımının engellenmesi
- B) Ön boynuz hücresinde dopamin sentezinin artırılması
- C) İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi
- D) Periferik sinirde miyelin sentezinin doğrudan baskılanması
- E) Kas hücresinde ryanodin reseptörlerinin sürekli açılması

Doğru Cevap: İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi

- A) Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımının engellenmesi: Nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımının engellenmesi botulizm mekanizmasıdır ve flask paralizi beklenir. Bu olguda "Kirli derin yara öyküsü vardır." ve "Aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Ön boynuz hücresinde dopamin sentezinin artırılması: Vakadaki Kirli derin yara öyküsü vardır ve Aşı öyküsü belirsizdir. Bu olguda "Kirli derin yara öyküsü vardır." ve "Aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi: İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi tetanozda trismus ve kas spazmlarının temel nedenidir. Vakadaki "Kirli derin yara öyküsü vardır." ve "Aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- D) Periferik sinirde miyelin sentezinin doğrudan baskılanması: Periferik sinirde miyelin sentezinin baskılanması demiyelinizan nöropati mekanizmasıdır düşündürür; akut tetanik spazm tablosunu açıklamaz. Bu olguda "Kirli derin yara öyküsü vardır." ve "Aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Kas hücresinde ryanodin reseptörlerinin sürekli açılması: Ryanodin reseptörlerinin sürekli açılması malign hipertermi mekanizmasıyla ilişkilidir; bu hastadaki toksin aracılı disinhibisyonu açıklamaz. Bu olguda "Kirli derin yara öyküsü vardır." ve "Aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kirli yara sonrası kas spazmları olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Kirli derin yara öyküsü vardır." ve "Aşı öyküsü belirsizdir." birlikte okunduğunda İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi seçeneği öne çıkar; "Trismus ve uyarıyla artan yaygın kas spazmları izlenmektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kirli derin yara sonrası trismus ve uyarıyla artan yaygın kas spazmları tetanoz tablosunu düşündürür. Tetanospazmin merkezi sinir sisteminde inhibitör internöronlara taşınır ve gama-aminobütirik asit ile glisin salınımını engelleyerek motor nöronların kontrolsüz aktivasyonuna yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Kirli derin yara öyküsü vardır.", "Aşı öyküsü belirsizdir." ve "Trismus ve uyarıyla artan yaygın kas spazmları izlenmektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İnhibitör internöronlardan gama-aminobütirik asit ve glisin salınımının engellenmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kirli derin yara öyküsü vardır.

Kanıt 2: Aşı öyküsü belirsizdir.

Kanıt 3: Trismus ve uyarıyla artan yaygın kas spazmları izlenmektedir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Tetanozda sorun asetilkolin artışı değil, inhibitör nörotransmitter salınımının engellenmesiyle gelişen disinhibisyonudur.

BRANŞ: general-surgery

VAKA 74: v172-new-074-siddetli-karin-agrisi-ve-atriyal-fibrilasyon

Başlık: Şiddetli karın ağrısı ve atriyal fibrilasyon

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik şüpheyi uygun tanısal yöntemle eşleştirme.

Learning Target: Akut mezenter iskemi şüphesinde en uygun tanısal görüntülemeyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan çok şiddetli karın ağrısı nedeniyle acile getiriliyor. Ağrının iki saat önce aniden başladığını ve muayeneye göre çok daha şiddetli hissedildiğini belirtiyor. Bilinen atriyal fibrilasyon öyküsü vardır ve antikoagülanını son haftalarda düzenli kullanmadığı öğreniliyor. Kusma ve dışkılama isteği eşlik etmiştir.

Demografi: 76 yaşında erkek hasta | Setting: Acil serviste

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/68 mmHg | Nabız: 126/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,21 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta huzursuz ve ağrılıdır.
- Batın yumuşak olup erken dönemde belirgin defans yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Doku hipoperfüzyonu ve iskemi riskini destekler. | Sonuç yorumu: Doku hipoperfüzyonu ve iskemi riskini destekler. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Doku hipoperfüzyonu ve iskemi riskini destekler. | Satırlar: Serum laktat / 5.8 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L / Doku hipoperfüzyonu ve iskemi riskini destekler.

Tetkik 2: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut stres ve inflamatuvar yanıtı destekler. | Sonuç yorumu: Akut stres ve inflamatuvar yanıtı destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut stres ve inflamatuvar yanıtı destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 18400 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Akut stres ve inflamatuvar yanıtı destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada tanıyı hızlıca değerlendirmek için en uygun görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ayakta direkt karın grafisi
B) Abdominal ultrasonografi
C) Kolonoskopi
D) Kontrastlı BT anjiyografi
E) Elektif ince bağırsak pasaj grafisi

Doğru Cevap: Kontrastlı BT anjiyografi

- A) Ayakta direkt karın grafisi: Ayakta direkt karın grafisi perforasyon veya obstrüksiyon bulgusu gösterebilir ancak mezenterik damar tıkanıklığını güvenilir biçimde değerlendirmez. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur." ve "Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir." ipuçları tanısal karar açısından Kontrastlı BT anjiyografi seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Abdominal ultrasonografi: Abdominal ultrasonografi safra ve bazı vasküler durumlarda yararlı olabilir ancak akut mezenter iskemi şüphesinde en hızlı ve kapsamlı yöntem değildir. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur." ve "Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir." ipuçları tanısal karar açısından Kontrastlı BT anjiyografi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Kolonoskopi: Kolonoskopi mukozal hastalıkları değerlendirebilir fakat akut embolik mezenter iskemi şüphesinde ilk hızlı vasküler görüntüleme değildir. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur." ve "Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir." ipuçları tanısal karar açısından Kontrastlı BT anjiyografi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Kontrastlı BT anjiyografi: Kontrastlı BT anjiyografi mezenter damar açıklığını ve bağırsak iskemi bulgularını hızlıca gösterdiği için bu hastada en uygun görüntülemedir. Vakadaki "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur." ve "Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- E) Elektif ince bağırsak pasaj grafisi: Elektif ince bağırsak pasaj grafisi kronik pasaj sorunlarında kullanılabilir; akut vasküler acil durumda tanıyı geciktirir. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur." ve "Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir." ipuçları tanısal karar açısından Kontrastlı BT anjiyografi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Şiddetli karın ağrısı ve atriyal fibrilasyon olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur." ve "Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir." birlikte okunduğunda Kontrastlı BT anjiyografi seçeneği öne çıkar; "Serum laktat yüksekliği doku hipoperfüzyonunu destekler." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Atriyal fibrilasyonu olan hastada ani başlayan, fizik muayene bulgularına göre orantısız şiddetli karın ağrısı ve laktat yüksekliği akut mezenter iskemi şüphesini doğurur. Hem arteriyel tıkanıklığı hem de bağırsak duvarı etkilenimini hızlı değerlendirmek için kontrastlı BT anjiyografi en uygun tanısal görüntülemedir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur.", "Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir." ve "Serum laktat yüksekliği doku hipoperfüzyonunu destekler." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kontrastlı BT anjiyografi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı embolik risk oluşturur.

Kanıt 2: Karın ağrısı muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.

Kanıt 3: Serum laktat yüksekliği doku hipoperfüzyonunu destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Muayeneye göre orantısız şiddetli karın ağrısı ve emboli riski akut mezenter iskemi için kritik ipucudur; tanıda BT anjiyografi ön plandadır.

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 75: v172-new-075-servikal-lenf-nodu-ile-saptanan-tiroid-nodulu

Başlık: Servikal lenf nodu ile saptanan tiroid nodülü

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik ve morfolojik bulguları patolojik paternle ilişkilendirme.

Learning Target: Papiller tiroid karsinomunun karakteristik histopatolojik bulgularını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, boyunda yavaş büyüyen şişlik ve ultrasonografide saptanan tiroid nodülü nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık altı aydır boynun ön kısmında küçük bir kitle fark ettiğini ve son dönemde sağ servikal bölgede ağrısız bir lenf nodu belirginleştiğini ifade ediyor. Çocukluk döneminde boyun bölgesine radyasyon alma öyküsü vardır.

Demografi: 34 yaşında kadın hasta | Setting: Endokrin cerrahi polikliniğinde

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Tiroid sağ lobunda sert, sınırları düzensiz nodül palpe edilir.
- Sağ lateral servikal bölgede hareketli, ağrısız lenf nodu vardır.
- Ses kısıklığı yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tiroid ultrasonografisi

Etiket: Tiroid ultrasonografisi | Tip: ultrasound | Alt tip: Ultrasonografi | Özet: Mikrokalsifikasyonlar içeren hipoeoik solid nodül izlendi. | Klinik anlam: Malignite şüphesini artıran sonografik özellikler taşır. | Sonuç yorumu: Malignite şüphesini artıran sonografik özellikler taşır. | Sonuç başlığı: Tiroid ultrasonografisi | Sonuç özeti: Mikrokalsifikasyonlar içeren hipoeoik solid nodül izlendi. | Yorum: Malignite şüphesini artıran sonografik özellikler taşır. | Satırlar: Tiroid ultrasonografisi / Mikrokalsifikasyonlar içeren hipoeoik solid nodül izlendi. // Malignite şüphesini artıran sonografik özellikler taşır.

Tetkik 2: İnce iğne aspirasyon sitolojisi

Etiket: İnce iğne aspirasyon sitolojisi | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Nükleer oluklanma, psödoinklüzyonlar ve psammoma cisimcikleri ile uyumlu hücre grupları görüldü. | Klinik anlam: Tümör tipini düşündüren sitolojik bulgulardır. | Sonuç yorumu: Tümör tipini düşündüren sitolojik bulgulardır. | Sonuç başlığı: İnce iğne aspirasyon sitolojisi | Sonuç özeti: Nükleer oluklanma, psödoinklüzyonlar ve psammoma cisimcikleri ile uyumlu hücre grupları görüldü. | Yorum: Tümör tipini düşündüren sitolojik bulgulardır. | Satırlar: İnce iğne aspirasyon sitolojisi / Nükleer oluklanma, psödoinklüzyonlar ve psammoma cisimcikleri ile uyumlu hücre grupları görüldü. // Tümör tipini düşündüren sitolojik bulgulardır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-041 | Başlık: Tiroid ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Mikrokalsifikasyonlar içeren hipoeoik solid nodül izlendi. | Klinik anlam: Malignite şüphesini artıran sonografik özellikler taşır. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/041_041-tiroid-mikrokalsifikasyonlu-hipoeoik-nodul-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/041_041-tiroid-mikrokalsifikasyonlu-hipoeoik-nodul-ultrasonografi.webp | Alt text: Tiroid ultrasonografisi - Mikrokalsifikasyonlar içeren hipoeoik solid nodül izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-042 | Başlık: İnce iğne aspirasyon sitolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Nükleer oluklanma, psödoinklüzyonlar ve psammoma cisimcikleri ile uyumlu hücre grupları görüldü. | Klinik anlam: Tümör tipini düşündüren sitolojik bulgulardır. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/042_042-papiller-tiroid-karsinomu-iaa-sitoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/042_042-papiller-tiroid-karsinomu-iaa-sitoloji.webp | Alt text: İnce iğne aspirasyon sitolojisi - Nükleer oluklanma, psödoinklüzyonlar ve psammoma cisimcikleri ile uyumlu hücre grupları görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada beklenen karakteristik patolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Amiloid stromada kalsitonin üreten C hücre proliferasyonu
- B) Kapsül ve damar invazyonu gösteren uniform folliküler hücreler
- C) Anaplastik dev hücreler ve yaygın nekroz
- D) Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri
- E) Granülomatöz inflamasyon ve multinükleer dev hücreler

Doğru Cevap: Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri

A) Amiloid stromada kalsitonin üreten C hücre proliferasyonu: Amiloid stromada kalsitonin üreten C hücre proliferasyonu medüller tiroid karsinomu için tipiktir; bu olguda papiller nükleer bulgular verilmiştir. Bu olguda "Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir." ve "Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler." ipuçları klinik karar açısından Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Kapsül ve damar invazyonu gösteren uniform folliküler hücreler: Kapsül ve damar invazyonu gösteren uniform folliküler hücreler folliküler tiroid karsinomunu düşündürür; servikal lenf nodu ve psammoma cisimciği paterni farklıdır. Bu olguda "Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir." ve "Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler." ipuçları klinik karar açısından Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Anaplastik dev hücreler ve yaygın nekroz: Anaplastik dev hücreler ve yaygın nekroz agresif anaplastik karsinomla ilişkilidir; genç hastadaki sitolojik bulgular bu tabloya uymaz. Bu olguda "Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir." ve "Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler." ipuçları klinik karar açısından Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri: Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri papiller tiroid karsinomunun karakteristik patolojik bulgularıdır. Vakadaki "Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir." ve "Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Granülomatöz inflamasyon ve multinükleer dev hücreler: Granülomatöz inflamasyon ve multinükleer dev hücreler subakut tiroidit gibi inflamatuvar süreçleri düşündürür; malign sitolojik paternle uyumlu değildir. Bu olguda "Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir." ve "Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler." ipuçları klinik karar açısından Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Servikal lenf nodu ile saptanan tiroid nodülü olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir." ve "Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler." birlikte okunduğunda Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri seçeneği öne çıkar; "Sitolojide nükleer oluklanma, psödoinklüzyon ve psammoma cisimcikleri belirtilmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Mikrokalsifikasyonlu tiroid nodülü, servikal lenf nodu tutulumu ve sitolojide nükleer oluklanma, psödoinklüzyon ve psammoma cisimcikleri papiller tiroid karsinomunu düşündürür. Bu tümörde berrak görünümlü Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri klasik patolojik ipuçlarıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir.", "Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler." ve "Sitolojide nükleer oluklanma, psödoinklüzyon ve psammoma cisimcikleri belirtilmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Orphan Annie eye nükleusları ve psammoma cisimcikleri en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyonlar izlenmiştir.

Kanıt 2: Servikal lenf nodu büyümesi lenfatik yayılım olasılığını destekler.

Kanıt 3: Sitolojide nükleer oluklanma, psödoinklüzyon ve psammoma cisimcikleri belirtilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Papiller tiroid karsinomu lenfatik yayılım yapar ve Orphan Annie eye nükleusları ile psammoma cisimcikleri klasik bulgulardır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 76: v172-new-076-hiperurisemi-ve-davranissal-bulgular

Başlık: Hiperürisemi ve davranışsal bulgular

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik ve objektif verileri temel patofizyolojik mekanizmayla ilişkilendirme.

Learning Target: Lesch-Nyhan sendromunda purin kurtarma yolu enzim defektini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, tekrarlayan eklem ağrıları, idrarda kristal görülmesi ve kendine zarar verme davranışı nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun son yıllarda parmaklarını ve dudaklarını ısırma davranışı gösterdiğini, gelişim basamaklarının geciktiğini ve zaman zaman idrarında kum benzeri tortular fark edildiğini belirtiyor. Ailede erkek akrabalarda benzer nörolojik sorun öyküsü vardır.

Demografi: 7 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk metabolizma polikliniğinde

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Çocukta distonik hareketler ve hafif spastisite izlenir.
- Dudaklarda ısırmağa bağlı skar alanları vardır.
- Eklem muayenesinde sağ ayak başparmağı çevresinde hassasiyet mevcuttur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum ürik asit

Etiket: Serum ürik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Purin metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Purin metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Serum ürik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Purin metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Serum ürik asit / 10.8 mg/dL / 2.0-5.5 mg/dL / Purin metabolizması bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: İdrar mikroskopisi

Etiket: İdrar mikroskopisi | Tip: microscopy | Alt tip: Mikroskopi | Özet: Ürat kristalleri izlendi. | Klinik anlam: Hiperürikozüriyi destekler. | Sonuç yorumu: Hiperürikozüriyi destekler. | Sonuç başlığı: İdrar mikroskopisi | Sonuç özeti: Ürat kristalleri izlendi. | Yorum: Hiperürikozüriyi destekler. | Satırlar: İdrar mikroskopisi / Ürat kristalleri izlendi. // Hiperürikozüriyi destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-043 | Başlık: İdrar mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Ürat kristalleri izlendi. | Klinik anlam: Hiperürikozüriyi destekler. | URL:

https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/043_043-urat-kristalleri-ıdrar-mikroskopisi.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/043_043-urat-kristalleri-ıdrar-mikroskopisi.webp | Alt text: İdrar mikroskopisi - Ürat kristalleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki temel biyokimyasal defekt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği
B) Adenozin deaminaz eksikliği
C) Ksantin oksidaz eksikliği
D) Dihidrofolat redüktaz eksikliği
E) Orotat fosforiboziltransferaz eksikliği

Doğru Cevap: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği

A) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği purin kurtarma yolunu bozarak hiperurisemi ve nörodavranışsal bulgulara yol açar. Vakadaki “Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.” ve “Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Adenozin deaminaz eksikliği: Adenozin deaminaz eksikliği ağır kombine immün yetmezlikle ilişkilidir; hiperurisemi ve kendine zarar verme davranışını açıklamaz. Bu olguda “Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.” ve “Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Ksantin oksidaz eksikliği: Ksantin oksidaz eksikliği ürik asit üretimini azaltır; bu hastadaki belirgin hiperüriseminin nedeni değildir. Bu olguda “Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.” ve “Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Dihidrofolat redüktaz eksikliği: Dihidrofolat redüktaz eksikliği folat metabolizması ve DNA senteziyle ilişkilidir; purin kurtarma yolu kliniğini açıklamaz. Bu olguda “Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.” ve “Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Orotat fosforiboziltransferaz eksikliği: Orotat fosforiboziltransferaz eksikliği orotik asidüriyle ilişkilidir; hiperurisemi ve kendine zarar verme davranışı paternine uymaz. Bu olguda “Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.” ve “Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hiperurisemi ve davranışsal bulgular olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.” ve “Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.” birlikte okunduğunda Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneği öne çıkar; “İdrarda ürat kristalleri görülmesi purin yıkım ürünlerinin arttığını destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erkek çocukta nörolojiksel bozukluk, kendine zarar verme davranışı, distoni, hiperurisemi ve ürat kristalleri Lesch-Nyhan sendromunu düşündürür. Temel defekt purin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliğidir; bu durum purinlerin yıkıma gitmesini artırarak ürik asit üretimini yükseltir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.”, “Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.” ve

“İdrarda ürat kristalleri görülmesi purin yıkım ürünlerinin arttığını destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular verilmiştir.

Kanıt 2: Serum ürik asit düzeyi belirgin yüksektir.

Kanıt 3: İdrarda ürat kristalleri görülmesi purin yıkım ürünlerinin arttığını destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Lesch-Nyhan sendromu X’e bağlıdır; hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği, hiperürisemi ve kendine zarar verme davranışıyla hatırlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 77: v172-new-077-antikoagulan-tedavi-sirasinda-yeni-tromboz

Başlık: Antikoagülan tedavi sırasında yeni tromboz

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tedavi önceliğini klinik güvenlik ve karar sırasına göre belirleme.

Learning Target: Heparin ilişkili trombositopenide uygun antikoagülan yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kalça ameliyatı sonrası profilaktik antikoagülan kullanırken bacakta ağrı ve şişlik gelişmesi nedeniyle konsülte ediliyor. Beş gündür unfractionated heparin profilaksisi aldığı, bugün sol baldırda ağrı ve şişlik başladığı öğreniliyor. Öncesinde bilinen trombositopeni öyküsü yoktur.

Demografi: 63 yaşında erkek hasta | Setting: Ortopedi servisi yatışı sırasında

Vital Bulgular

Kan basıncı: 126/78 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,73

Fizik Muayene

- Sol baldır sağa göre daha şiş ve hassastır.
- Ciltte yaygın peteşi yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Başlangıç değerine göre belirgin düşüş saptandı. | Klinik anlam: Heparin kullanımı sırasında gelişen anlamlı düşüş mevcuttur. | Sonuç yorumu: Heparin kullanımı sırasında gelişen anlamlı düşüş mevcuttur. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Başlangıç değerine göre belirgin düşüş saptandı. | Yorum: Heparin kullanımı sırasında gelişen anlamlı düşüş mevcuttur. | Satırlar: Trombosit sayısı / 78000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Heparin kullanımı sırasında gelişen anlamlı düşüş mevcuttur.

Tetkik 2: Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi

Etiket: Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi | Tip: ultrasound | Alt tip: Ultrasonografi | Özet: Sol popliteal vende akut trombüs izlendi. | Klinik anlam: Trombositopeniye rağmen trombotik komplikasyonu gösterir. | Sonuç yorumu: Trombositopeniye rağmen trombotik komplikasyonu gösterir. | Sonuç başlığı: Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi | Sonuç özeti: Sol popliteal vende akut trombüs izlendi. | Yorum: Trombositopeniye rağmen trombotik komplikasyonu gösterir. | Satırlar: Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi / Sol popliteal vende akut trombüs izlendi. / / Trombositopeniye rağmen trombotik komplikasyonu gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-044 | Başlık: Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sol popliteal vende akut trombüs izlendi. | Klinik anlam: Trombositopeniye rağmen trombotik komplikasyonu gösterir. | URL:

https://iukbtlkzixctqds.public.blob.vercel-storage.com/044_044-popliteal-ven-akut-trombus-doppler-ultrasonografi.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzixctqds.public.blob.vercel-storage.com/044_044-popliteal-ven-akut-trombus-doppler-ultrasonografi.webp | Alt text: Alt ekstremitte venöz Doppler ultrasonografi - Sol popliteal vende akut trombüs izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-272 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Ciltte yaygın peteşi yoktur. | Klinik anlam: Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması | URL: https://iukbtlkzixctqds.public.blob.vercel-storage.com/272_medical_exam_room_close_up_of_leg.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzixctqds.public.blob.vercel-storage.com/272_medical_exam_room_close_up_of_leg.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Ciltte yaygın peteşi yoktur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun antikoagülan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Heparine aynı dozda devam edilmesi
- B) Heparinin kesilip varfarinin tek başına hemen başlanması
- C) Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması
- D) Trombosit transfüzyonu sonrası antikoagülasyonu keserek izlem planlamak
- E) Düşük doz aspirin ile izlem yapılması

Doğru Cevap: Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması

A) Heparine aynı dozda devam edilmesi: Heparine devam etmek antikor aracılı trombosit aktivasyonunu sürdürebilir ve yeni tromboz riskini artırır. Bu olguda “Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.” ve “Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Heparinin kesilip varfarinin tek başına hemen başlanması: Varfarinin tek başına hemen başlanması erken dönemde protein C azalması nedeniyle trombotik riski artırabilir; önce non-heparin antikoagülan gerekir. Bu olguda “Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.” ve “Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması: Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması heparin ilişkili trombositopenide uygun tedavi yaklaşımıdır. Vakadaki “Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.” ve “Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

D) Trombosit transfüzyonu sonrası antikoagülasyonu keserek izlem planlamak: Vakadaki Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır ve Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir. Bu olguda “Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.” ve “Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Düşük doz aspirin ile izlem yapılması: Düşük doz aspirin venöz trombozu ve antikor aracılı trombosit aktivasyonunu tedavi etmek için yeterli değildir. Bu olguda “Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.” ve “Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antikoagülan tedavi sırasında yeni tromboz olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.” ve “Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması seçeneği öne çıkar; “Başlangıçta trombositopeni öyküsü olmaması ilaç ilişkili süreci destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Heparin başlandıktan 5 gün sonra trombosit sayısında belirgin düşüş ve yeni venöz tromboz gelişmesi heparin ilişkili immün trombositopeniyi düşündürür. Tedavide tüm heparin ürünleri kesilmeli ve trombin inhibitörü gibi non-heparin antikoagülan başlanmalıdır; varfarin tek başına erken dönemde başlanmamalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.”, “Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.” ve “Başlangıçta trombositopeni öyküsü olmaması ilaç ilişkili süreci destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Heparinin kesilip argatroban gibi non-heparin antikoagülan başlanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Trombosit düşüşü heparin kullanımının beşinci gününde ortaya çıkmıştır.

Kanıt 2: Trombositopeniye rağmen yeni popliteal ven trombozu gelişmiştir.

Kanıt 3: Başlangıçta trombositopeni öyküsü olmaması ilaç ilişkili süreci destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Heparin ilişkili trombositopeni kanamadan çok trombozla seyreder; heparin kesilir ve non-heparin antikoagülan başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 78: v172-new-078-yenidoganda-hipokalsemik-nobet

Başlık: Yenidoğanda hipokalsemik nöbet

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik ve objektif verileri temel patofizyolojik mekanizmayla ilişkilendirme.

Learning Target: DiGeorge sendromunda etkilenen faringeal poşları klinik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, tekrarlayan kasılma atakları ve beslenme güçlüğü nedeniyle değerlendirmeye alınıyor. Doğumdan sonra kardiyak üfürüm nedeniyle izleme alındığı, son günlerde emmesinin azaldığı ve iki kez kısa süreli kasılma yaşadığı öğreniliyor. Ailede benzer hastalık öyküsü bilinmiyor.

Demografi: 12 günlük erkek bebek | Setting: Yenidoğan servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 152/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 2,17 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek iritabl görünümündedir.
- Perioral seğirme ve karpopedal spazm izlenir.
- Sternum sol kenarında sistolik üfürüm duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kalsiyum

Etiket: Serum kalsiyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Tetani ve nöbet riskini açıklar. | Sonuç yorumu: Tetani ve nöbet riskini açıklar. | Sonuç başlığı: Serum kalsiyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Tetani ve nöbet riskini açıklar. | Satırlar: Serum kalsiyum / 6.4 mg/dL / 8.5-10.5 mg/dL / Tetani ve nöbet riskini açıklar.

Tetkik 2: Lenfosit alt grup analizi

Etiket: Lenfosit alt grup analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: T lenfosit sayısı düşük saptandı. | Klinik anlam: Timus gelişim bozukluğunu düşündürür. | Sonuç yorumu: Timus gelişim bozukluğunu düşündürür. | Sonuç başlığı: Lenfosit alt grup analizi | Sonuç özeti: T lenfosit sayısı düşük saptandı. | Yorum: Timus gelişim bozukluğunu düşündürür. | Satırlar: Lenfosit alt grup analizi / T lenfosit sayısı düşük saptandı. // Timus gelişim bozukluğunu düşündürür.

Tetkik 3: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: ultrasound | Alt tip: Ekokardiyografi | Özet: Konotrunkal kalp anomalisi ile uyumlu yapısal defekt izlendi. | Klinik anlam: Embriyolojik gelişim bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Embriyolojik gelişim bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Konotrunkal kalp anomalisi ile uyumlu yapısal defekt izlendi. | Yorum: Embriyolojik gelişim bozukluğunu destekler. | Satırlar: Ekokardiyografi / Konotrunkal kalp anomalisi ile uyumlu yapısal defekt izlendi. // Embriyolojik gelişim bozukluğunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-045 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Konotrunkal kalp anomalisi ile uyumlu yapısal defekt izlendi. | Klinik anlam: Embriyolojik gelişim bozukluğunu destekler. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/045_045-konotrunkal-kalp-anomalisi-ekokardiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/045_045-konotrunkal-kalp-anomalisi-ekokardiyografi.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Konotrunkal kalp anomalisi ile uyumlu yapısal defekt izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hipokalsemi ve T lenfosit düşüklüğünün embriyolojik temelinde en olası gelişim kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Birinci faringeal ark gelişim bozukluğu
- B) Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu
- C) Notochord regresyon kusuru
- D) Metanefrik blastem indüksiyon kusuru
- E) Septum primum rezorpsiyon artışı

Doğru Cevap: Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu

A) Birinci faringeal ark gelişim bozukluğu: Birinci faringeal ark mandibula, maksilla ve ilgili kas-sinir yapılarıyla ilişkilidir; timus ve paratiroid eksikliğini açıklamaz. Bu olguda “Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.” ve “T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.” ipuçları tanısallık karar açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu: Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu timus ile paratiroid yetersizliğini açıklayarak T lenfosit düşüklüğü ve hipokalsemiye yol açar. Vakadaki “Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.” ve “T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Notochord regresyon kusuru: Notochord regresyon kusuru aksiyel iskelet ve nöral gelişim sorunlarıyla ilişkilidir; bu immün-endokrin tabloyu açıklamaz. Bu olguda “Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.” ve “T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.” ipuçları tanısallık karar açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Metanefrik blastem indüksiyon kusuru: Metanefrik blastem indüksiyon kusuru böbrek gelişimiyle ilişkilidir; hipokalsemik tetani ve T hücre düşüklüğünün temel nedeni değildir. Bu olguda “Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.” ve “T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.” ipuçları tanısal karar açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Septum primum rezorpsiyon artışı: Septum primum rezorpsiyon artışı atriyal septal defekt mekanizmalarından biridir; paratiroid ve timus gelişimini açıklamaz. Bu olguda “Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.” ve “T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.” ipuçları tanısal karar açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda hipokalsemik nöbet olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.” ve “T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.” birlikte okunduğunda Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu seçeneği öne çıkar; “Ekokardiyografide konotrunkal kalp anomalisi gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipokalsemik tetani, T lenfosit düşüklüğü ve konotrunkal kalp anomalisi DiGeorge sendromunu düşündürür. Bu tabloda üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişimi bozulur; timus ve paratiroid gelişimindeki yetersizlik T hücre immün yetmezliği ve hipokalsemiye yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.”, “T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.” ve “Ekokardiyografide konotrunkal kalp anomalisi gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim bozukluğu en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Bebekte hipokalsemiye bağlı kasılma ve karpopedal spazm vardır.

Kanıt 2: T lenfosit sayısının düşük olması timus kaynaklı hücresel immün yetmezliği düşündürür.

Kanıt 3: Ekokardiyografide konotrunkal kalp anomalisi gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: DiGeorge sendromunda üçüncü ve dördüncü faringeal poş kusuru timus ve paratiroid gelişimini bozar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 79: v172-new-079-yanik-yarasinda-kotulesen-enfeksiyon

Başlık: Yanık yarasında kötüleşen enfeksiyon

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik ve objektif verileri temel patofizyolojik mekanizmayla ilişkilendirme.

Learning Target: Pseudomonas aeruginosa toksin mekanizmasını klinik ve laboratuvar bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yanık alanında kötü kokulu akıntı ve ateş gelişmesi nedeniyle yeniden değerlendiriliyor. Beş gün önce sıcak sıvı ile alt ekstremitelerinde geniş yanık geliştiği, hastanede yara bakımı aldığı öğreniliyor. Son 24 saatte ateş, titreme ve yara alanında renk değişikliği fark edilmiştir.

Demografi: 29 yaşında erkek hasta | Setting: Yanık ünitesinde takip edilirken

Vital Bulgular

Kan basıncı: 96/58 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 39.0°C | Şok indeksi: 1,27 (yüksek)

Fizik Muayene

- Yanık alanında mavimsi-yeşil renkli akıntı ve çevresinde hassasiyet vardır.
- Hasta toksik görünümündür.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yara kültürü

Etiket: Yara kültürü | Tip: microbiology | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Oksidaz pozitif, non-laktoz fermenter gram-negatif basil üredi. | Klinik anlam: Yanık yarası enfeksiyonu etkenini daraltır. | Sonuç yorumu: Yanık yarası enfeksiyonu etkenini daraltır. | Sonuç başlığı: Yara kültürü | Sonuç özeti: Oksidaz pozitif, non-laktoz fermenter gram-negatif basil üredi. | Yorum: Yanık yarası enfeksiyonu etkenini daraltır. | Satırlar: Yara kültürü | Oksidaz pozitif, non-laktoz fermenter gram-negatif basil üredi. // Yanık yarası enfeksiyonu etkenini daraltır.

Tetkik 2: Kültür görünümü

Etiket: Kültür görünümü | Tip: microbiology | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Mavi-yeşil pigment oluşturan koloniler izlendi. | Klinik anlam: Etkenin karakteristik pigment üretimini destekler. | Sonuç yorumu: Etkenin karakteristik pigment üretimini destekler. | Sonuç başlığı: Kültür görünümü | Sonuç özeti: Mavi-yeşil pigment oluşturan koloniler izlendi. | Yorum: Etkenin karakteristik pigment üretimini destekler. | Satırlar: Kültür görünümü | Mavi-yeşil pigment oluşturan koloniler izlendi. // Etkenin karakteristik pigment üretimini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu etkenin Exotoxin A aracılı temel hücresel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adenilat siklazı kalıcı aktive ederek sekretuar ishale neden olması
- B) Ribozomal 60S alt birimini doğrudan parçalaması
- C) Aktin polimerizasyonunu artırarak hücre içi hareket sağlaması
- D) Elongasyon faktörü-2'yi ADP-ribozillayarak protein sentezini inhibe etmesi
- E) Nöromusküler kavşakta asetilkolin salınımını engellemesi

Doğru Cevap: Elongasyon faktörü-2'yi ADP-ribozillayarak protein sentezini inhibe etmesi

A) Adenilat siklazı kalıcı aktive ederek sekretuar ishale neden olması: Adenilat siklazın kalıcı aktivasyonu kolera toksini gibi sekretuar ishal yapan toksin mekanizmalarında ön plandadır; bu yanık yara etkeninin Exotoxin A etkisi değildir. Bu olguda “Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.” ve “Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Elongasyon faktörü-2'yi ADP-ribozillayarak protein sentezini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Ribozomal 60S alt birimini doğrudan parçalaması: Ribozomal 60S alt biriminin doğrudan parçalanması Shiga toksini gibi mekanizmaları düşündürür; burada hedef elongasyon faktörü-2'dir. Bu olguda “Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.” ve “Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Elongasyon faktörü-2'yi ADP-ribozillayarak protein sentezini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Aktin polimerizasyonunu artırarak hücre içi hareket sağlaması: Aktin polimerizasyonunun artırılması Listeria monocytogenes gibi hücre içi hareket eden etkenlerle ilişkilidir; Pseudomonas Exotoxin A mekanizması değildir. Bu olguda “Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.” ve “Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Elongasyon faktörü-2'yi ADP-ribozillayarak protein sentezini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Elongasyon faktörü-2'yi ADP-ribozillayarak protein sentezini inhibe etmesi: Elongasyon faktörü-2'nin ADP-ribozillenmesi protein sentezini durduran Pseudomonas aeruginosa Exotoxin A mekanizmasıdır. Vakadaki “Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.” ve “Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Nöromusküler kavşakta asetilkolin salınımını engellemesi: Nöromusküler kavşakta asetilkolin salınımının engellenmesi botulinum toksini etkisidir; yanık yarısındaki bu etkenin toksiniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.” ve “Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Elongasyon faktörü-2’yi ADP-ribozilleyerek protein sentezini inhibe etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yanık yarısında kötüleşen enfeksiyon olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.” ve “Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.” birlikte okunduğunda Elongasyon faktörü-2’yi ADP-ribozilleyerek protein sentezini inhibe etmesi seçeneği öne çıkar; “Mavi-yeşil pigment oluşturan koloniler izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yanık yarısında mavi-yeşil pigmentli, oksidaz pozitif, non-laktoz fermenter gram-negatif basil Pseudomonas aeruginosa için tipiktir. Bu etkenin Exotoxin A toksini elongasyon faktörü-2’yi ADP-ribozilleyerek protein sentezini inhibe eder ve hücre hasarına yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.”, “Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.” ve “Mavi-yeşil pigment oluşturan koloniler izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Elongasyon faktörü-2’yi ADP-ribozilleyerek protein sentezini inhibe etmesi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Enfeksiyon geniş yanık alanında gelişmiştir.

Kanıt 2: Yara kültüründe oksidaz pozitif non-laktoz fermenter gram-negatif basil üremiştir.

Kanıt 3: Mavi-yeşil pigment oluşturan koloniler izlenmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Pseudomonas aeruginosa Exotoxin A, difteri toksinine benzer şekilde elongasyon faktörü-2 üzerinden protein sentezini inhibe eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 80: v172-new-080-kronik-karbondioksit-retansiyonu

Başlık: Kronik karbondioksit retansiyonu

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik ve objektif verileri temel patofizyolojik mekanizmayla ilişkilendirme.

Learning Target: Kronik respiratuvar asidozda renal kompanzasyon mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kronik nefes darlığında artış ve sabah baş ağrıları nedeniyle yatırılıyor. Uzun yıllardır kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı olduğu, son aylarda gündüz uyuklama ve sabah baş ağrılarının arttığı öğreniliyor. Sigara kullanımı devam etmektedir.

Demografi: 68 yaşında erkek hasta | Setting: Göğüs hastalıkları servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %88 | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta hafif siyanotik görünümündedir.
- Ekspiryum uzamış, bilateral solunum sesleri azalmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Kronik kompanse respiratuvar asidoz ile uyumlu değerler saptandı. | Klinik anlam: Karbondioksit retansiyonuna renal yanıt olduğunu gösterir. | Sonuç yorumu: Karbondioksit retansiyonuna renal yanıt olduğunu gösterir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Kronik kompanse respiratuvar asidoz ile uyumlu değerler saptandı. | Yorum: Karbondioksit retansiyonuna renal yanıt olduğunu gösterir. | Satırlar: Arter kan gazı | pH 7.36, PaCO₂ 62, HCO₃ 34 mmHg ve mmol/L | pH 7.35-7.45, PaCO₂ 35-45 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/L | Karbondioksit retansiyonuna renal yanıt olduğunu gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada pH değerinin normale yakın kalmasını sağlayan temel renal kompanzasyon mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bikarbonat atılımının artırılması ve idrarın alkalileştirilmesi
- B) Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi
- C) Glomerüler filtrasyonun tamamen durdurulması
- D) Distal tübülde potasyum geri emiliminin seçici olarak artırılması
- E) Toplayıcı kanalda su geçirgenliğinin tamamen ortadan kaldırılması

Doğru Cevap: Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi

A) Bikarbonat atılımının artırılması ve idrarın alkalileştirilmesi: Bikarbonat atılımının artırılması asidemiye kötüleştirir; kronik respiratuvar asidozda beklenen yanıt bikarbonat tutulumu ve üretimidir. Bu olguda “PaCO₂ değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.” ve “Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi: Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonunun artması bikarbonat geri kazanımını yükselterek kronik respiratuvar asidozu kompanse eder. Vakadaki “PaCO₂ değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.” ve “Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Glomerüler filtrasyonun tamamen durdurulması: Glomerüler filtrasyonun tamamen durması fizyolojik bir kompanzasyon değildir ve asit-baz dengesini korumaz. Bu olguda “PaCO₂ değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.” ve “Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Distal tübülde potasyum geri emiliminin seçici olarak artırılması: Potasyum geri emiliminin seçici artışı bu hastadaki yüksek bikarbonatlı pH kompanzasyonunu açıklayan temel mekanizma değildir. Bu olguda “PaCO₂ değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.” ve “Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Toplayıcı kanalda su geçirgenliğinin tamamen ortadan kaldırılması: Toplayıcı kanalda su geçirgenliğinin tamamen ortadan kalkması su dengesiyle ilişkilidir; karbondioksit retansiyonuna karşı pH kompanzasyonunu açıklamaz. Bu olguda “PaCO₂ değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.” ve “Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik karbondioksit retansiyonu olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “PaCO2 değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.” ve “Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.” birlikte okunduğunda amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi seçeneği öne çıkar; “pH değerinin normale yakın olması metabolik yanıtın etkili olduğunu gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik karbondioksit retansiyonu respiratuvar asidoz oluşturur. Böbrekler zamanla hidrojen iyonu sekresyonunu ve amonyagenezi artırarak asit atılımını yükseltir; aynı süreç bikarbonat geri kazanımı ve yeni bikarbonat üretimiyle pH değerinin normale yaklaşmasını sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “PaCO2 değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.”, “Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.” ve “pH değerinin normale yakın olması metabolik yanıtın etkili olduğunu gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Amonyagenez ve hidrojen iyonu sekresyonu artırılarak bikarbonat geri kazanımının yükseltilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: PaCO2 değeri kronik karbondioksit retansiyonunu gösterecek şekilde yüksektir.

Kanıt 2: Bikarbonat değerinin yüksek olması renal kompanzasyonu destekler.

Kanıt 3: pH değerinin normale yakın olması metabolik yanıtın etkili olduğunu gösterir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Kronik respiratuvar asidozda böbrek kompanzasyonu bikarbonatı artırır; akut tabloda bu yükselme belirgin değildir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 81: v173-new-081-yenidoganda-mekonyum-cikaramama

Başlık: Yenidoğanda mekonyum çıkaramama

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik bulguları temel mekanizma ile ilişkilendirme.

Learning Target: Hirschsprung hastalığında embriyolojik mekanizmayı klinik ve patolojik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan sonra mekonyum çıkaramama ve giderek artan karın şişliği nedeniyle değerlendirmeye alınıyor. Term doğduğu, doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde mekonyum çıkarmadığı ve beslenme sonrası kusmalarının başladığı öğreniliyor. Aile, dışkılama olmadıkça karın şişliğinin arttığını belirtiyor.

Demografi: 3 günlük erkek yenidoğan | Setting: Çocuk cerrahisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 154/dk | Solunum: 42/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 2,20 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek huzursuz ve batını belirgin distandü görünümündedir.
- Rektal tuşe sonrası gaz ve az miktarda dışkı çıkışı olduğu gözlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kontrastlı kolon grafisi

Etiket: Kontrastlı kolon grafisi | Tip: xray | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Distal rektosigmoid segmentte daralma ve proksimal kolonda belirgin genişleme izlendi. | Klinik anlam: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | Sonuç yorumu: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | Sonuç başlığı: Kontrastlı kolon grafisi | Sonuç özeti: Distal rektosigmoid segmentte daralma ve proksimal kolonda belirgin genişleme izlendi. | Yorum: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | Satırlar: Kontrastlı kolon grafisi / Distal rektosigmoid segmentte daralma ve proksimal kolonda belirgin genişleme izlendi. // Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler.

Tetkik 2: Rektal biyopsi

Etiket: Rektal biyopsi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Submukozal ve miyenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Klinik anlam: Enterik sinir sistemi gelişim kusurunu gösterir. | Sonuç yorumu: Enterik sinir sistemi gelişim kusurunu gösterir. | Sonuç başlığı: Rektal biyopsi | Sonuç özeti: Submukozal ve miyenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Yorum: Enterik sinir sistemi gelişim kusurunu gösterir. | Satırlar: Rektal biyopsi / Submukozal ve miyenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. // Enterik sinir sistemi gelişim kusurunu gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-046 | Başlık: Kontrastlı kolon grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Distal rektosigmoid segmentte daralma ve proksimal kolonda belirgin genişleme izlendi. | Klinik anlam: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/046_046-hirschsprung-gecis-zonu-kontrastli-kolon-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/046_046-hirschsprung-gecis-zonu-kontrastli-kolon-grafisi.webp | Alt text: Kontrastlı kolon grafisi - Distal rektosigmoid segmentte daralma ve proksimal kolonda belirgin genişleme izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-047 | Başlık: Rektal biyopsi | Modalite: microscopy | Bulgu: Submukozal ve miyenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Klinik anlam: Enterik sinir sistemi gelişim kusurunu gösterir. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/047_047-aganglionozis-rektal-biyopsi-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/047_047-aganglionozis-rektal-biyopsi-histopatoloji.webp | Alt text: Rektal biyopsi - Submukozal ve miyenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki tablonun temel embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması
- B) Ürakuşun persiste açık kalması
- C) Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma
- D) Midgutun fizyolojik herniasyon sonrası karın boşluğuna dönememesi
- E) Kloakal membranın doğumdan önce rüptüre olmaması

Doğru Cevap: Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma

A) Omfalomezenterik kanalın tam kapanmaması: Omfalomezenterik kanalın kapanmaması Meckel divertikülü gibi kalıntılara yol açar; distal aganglionik kolon bulgusunu açıklamaz. Bu olguda “Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Ürakuşun persiste açık kalması: Ürakuşun açık kalması umbilikustan idrar gelmesiyle ilişkilidir; bağırsak pleksuslarında ganglion hücresi yokluğuna neden olmaz. Bu olguda “Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma: Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma enterik pleksus aganglionozisine yol açarak bu fonksiyonel obstrüksiyon tablosunu açıklar. Vakadaki “Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Midgutun fizyolojik herniasyon sonrası karın boşluğuna dönememesi: Midgutun karın boşluğuna dönememesi omfalosel gibi karın duvarı defektleriyle ilişkilidir; rektosigmoid aganglionozisi açıklamaz. Bu olguda “Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kloakal membranin doğumdan önce rüptüre olmaması: Kloakal membranin rüptüre olmaması anal açıklık anomalileriyle ilişkilidir; burada biyopsiyle gösterilen enterik ganglion eksikliği belirleyicidir. Bu olguda “Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda mekonyum çıkaramama olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma seçeneği öne çıkar; “Rektal biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda mekonyum çıkaramama, karın distansiyonu, distal dar segment ve rektal biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu Hirschsprung hastalığını düşündürür. Temel embriyolojik kusur nöral krest kökenli enterik ganglion hücrelerinin distal bağırsak segmentine göç edememesidir; aganglionik segment gevşeyemez ve fonksiyonel obstrüksiyon gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.”, “Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.” ve “Rektal biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göçünde bozulma en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Bebek doğumdan sonraki ilk 48 saatte mekonyum çıkaramamıştır.

Kanıt 2: Kontrastlı grafide distal daralma ve proksimal genişleme izlenmiştir.

Kanıt 3: Rektal biyopside ganglion hücrelerinin yokluğu gösterilmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Hirschsprung hastalığında distal aganglionik segment gevşeyemez; neden nöral krest hücre göç kusurudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 82: v173-new-082-beslenmeyle-artan-solunum-sikintisi

Başlık: Beslenmeyle artan solunum sıkıntısı

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik bulguları temel mekanizma ile ilişkilendirme.

Learning Target: Trakeoözofageal fistülün gelişimsel temelini klinik bulgularla açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, ilk beslenme denemelerinde öksürük, morarma ve ağızda köpüklü sekresyon nedeniyle izleniyor. Gebelikte polihidramniyoz saptaandığı, doğumdan sonra bebeğin ağız sekresyonlarının fazla olduğu öğreniliyor. İlk oral beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmiştir.

Demografi: 1 günlük kız yenidoğan | Setting: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 148/dk | Solunum: 54/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebekte ağız ve burunda köpüklü sekresyonlar vardır.
- Beslenme denemesiyle öksürük ve oksijen satürasyonunda düşme izlenir.
- Batın hafif distandüdü.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Nazogastrik sonda ilerletme denemesi

Etiket: Nazogastrik sonda ilerletme denemesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sonda üst mediasten düzeyinde ilerlemeyip kıvrıldı. | Klinik anlam: Özofagus devamlılığında kesinti olduğunu düşündürür. | Sonuç yorumu: Özofagus devamlılığında kesinti olduğunu düşündürür. | Sonuç başlığı: Nazogastrik sonda ilerletme denemesi | Sonuç özeti: Sonda üst mediasten düzeyinde ilerlemeyip kıvrıldı. | Yorum: Özofagus devamlılığında kesinti olduğunu düşündürür. | Satırlar: Nazogastrik sonda ilerletme denemesi / Sonda üst mediasten düzeyinde ilerlemeyip kıvrıldı. // Özofagus devamlılığında kesinti olduğunu düşündürür.

Tetkik 2: Direkt grafi

Etiket: Direkt grafi | Tip: radyo | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Nazogastrik sondanın proksimal özofagusta kıvrıldığı ve batında gaz bulunduğu izlendi. | Klinik anlam: Distal hava yolu bağlantısını düşündüren radyolojik bulgudur. | Sonuç yorumu: Distal hava yolu bağlantısını düşündüren radyolojik bulgudur. | Sonuç başlığı: Direkt grafi | Sonuç özeti: Nazogastrik sondanın proksimal özofagusta kıvrıldığı ve batında gaz bulunduğu izlendi. | Yorum: Distal hava yolu bağlantısını düşündüren radyolojik bulgudur. | Satırlar: Direkt grafi / Nazogastrik sondanın proksimal özofagusta kıvrıldığı ve batında gaz bulunduğu izlendi. // Distal hava yolu bağlantısını düşündüren radyolojik bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-048 | Başlık: Direkt grafi | Modalite: xray | Bulgu: Nazogastrik sondanın proksimal özofagusta kıvrıldığı ve batında gaz bulunduğu izlendi. | Klinik anlam: Distal hava yolu bağlantısını düşündüren radyolojik bulgudur. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/048_048-ozofagus-atrezisi-trakeoofageal-fistul-direkt-grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/048_048-ozofagus-atrezisi-trakeoofageal-fistul-direkt-grafi.webp | Alt text: Direkt grafi - Nazogastrik sondanın proksimal özofagusta kıvrıldığı ve batında gaz bulunduğu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki anomalinin embriyolojik temelinde en olası mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç edememesi
- B) Üçüncü ve dördüncü faringeal poşların gelişememesi
- C) Septum transversumun diyafram gelişimine katılamaması
- D) Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması
- E) Omfalomezenterik kanalın ileumla bağlantısını sürdürmesi

Doğru Cevap: Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması

- A) Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç edememesi: Nöral krest hücrelerinin konotrunkal bölgeye göç edememesi kardiyak çıkış yolu anomalileriyle ilişkilidir; özofagus-hava yolu bağlantısını açıklamaz. Bu olguda “Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.” ve “Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.” ipuçları tanısall kararl karar açısından Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Üçüncü ve dördüncü faringeal poşların gelişememesi: Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru timus ve paratiroid anomalilerine yol açar; beslenmeyle aspirasyon tablosunun nedeni değildir. Bu olguda “Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.” ve “Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.” ipuçları tanısall kararl karar açısından Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Septum transversum diyafram gelişimine katılamaması: Septum transversum diyafram gelişiminde rol alır; proksimal özofagus atrezisi ve distal fistül paternini açıklamaz. Bu olguda “Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.” ve “Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.” ipuçları tanısall kararl karar açısından Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması: Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması bu hastadaki özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül tablosunu açıklar. Vakadaki “Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.” ve “Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Omfalomezenterik kanalı ile omfalomezenterik bağılantısını sürdürmesi: Omfalomezenterik kanalın persiste olması Meckel divertikülü gibi ileal kalıntılar oluşturur; hava yolu-özofagus bağılantısıyla ilişkili değildir. Bu olguda “Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.” ve “Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Beslenmeyle artan solunum sıkıntısı olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.” ve “Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.” birlikte okunduğunda Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması seçeneği öne çıkar; “Nazogastrik sonda proksimal özofagusta kıvrılırken batında gaz izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Beslenmeyle öksürük ve siyanoz, ağızda köpüklü sekresyon, nazogastrik sondanın ilerlememesi ve batında gaz bulunması özofagus atrezisi ile distal trakeoözofageal fistülü düşündürür. Bu anomalinin temelinde ön bağırsağın ventral respiratuvar divertikül ve dorsal özofagus olarak ayrılmasındaki trakeoözofageal septasyon kusuru yer alır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.”, “Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.” ve “Nazogastrik sonda proksimal özofagusta kıvrılırken batında gaz izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılmasını sağlayan septasyonun bozulması en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Gebelikte polihidramniyoz öyküsü vardır.

Kanıt 2: Beslenme sırasında öksürük ve siyanoz gelişmektedir.

Kanıt 3: Nazogastrik sonda proksimal özofagusta kıvrılırken batında gaz izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül ön bağırsak septasyon kusurudur; beslenmeyle öksürük ve siyanoz tipiktir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 83: v173-new-083-atipik-pnomoni-ve-hiponatremi

Başlık: Atipik pnömoni ve hiponatremi

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik ve laboratuvar ipuçlarından etkeni belirleme.

Learning Target: Legionella pnömonisinde klinik ipuçları ve tanısız testi ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı nedeniyle acile başvuruyor. Üç gün önce otelde konakladığı ve havuz-spa alanını kullandığı öğreniliyor. Ateşe ishal, baş ağrısı ve belirgin halsizlik eşlik etmektedir. Sigara öyküsü vardır.

Demografi: 61 yaşında erkek hasta | Setting: Acil serviste

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 39.4°C | Şok indeksi: 0,95 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta toksik ve takipneik görünümündedir.
- Sağ alt akciğer alanında inspiratuvar ral duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Atipik pnömoni etkeni açısından destekleyici ipucudur. | Sonuç yorumu: Atipik pnömoni etkeni açısından destekleyici ipucudur. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Atipik pnömoni etkeni açısından destekleyici ipucudur. | Satırlar: Serum sodyum / 126 mmol/L / 135-145 mmol/L / Atipik pnömoni etkeni açısından destekleyici ipucudur.

Tetkik 2: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: xray | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ alt lobda yamalı infiltrasyon izlendi. | Klinik anlam: Pnömoni varlığını destekler. | Sonuç yorumu: Pnömoni varlığını destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Sağ alt lobda yamalı infiltrasyon izlendi. | Yorum: Pnömoni varlığını destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Sağ alt lobda yamalı infiltrasyon izlendi. // Pnömoni varlığını destekler.

Tetkik 3: İdrar antijen testi

Etiket: İdrar antijen testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Atipik pnömoni etkenini destekler. | Sonuç yorumu: Atipik pnömoni etkenini destekler. | Sonuç başlığı: İdrar antijen testi | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Atipik pnömoni etkenini destekler. | Satırlar: İdrar antijen testi / Pozitif saptandı. // Atipik pnömoni etkenini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-049 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ alt lobda yamalı infiltrasyon izlendi. | Klinik anlam: Pnömoni varlığını destekler. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/049_049-sag-alt-lob-pnomoni-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/049_049-sag-alt-lob-pnomoni-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Sağ alt lobda yamalı infiltrasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Streptococcus pneumoniae
B) Legionella pneumophila
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Chlamydia psittaci
E) Klebsiella pneumoniae

Doğru Cevap: Legionella pneumophila

A) Streptococcus pneumoniae: Streptococcus pneumoniae tipik lobar pnömoninin sık etkenidir ancak su sistemi maruziyeti, ishal ve hiponatremi kombinasyonu bu olguda daha farklı bir etkeni öne çıkarır. Bu olguda “Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.” ve “Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Legionella pneumophila: Legionella pneumophila otel-spa maruziyeti, atipik pnömoni, gastrointestinal bulgular, hiponatremi ve idrar antijen pozitifliğiyle en uyumlu etkindir. Vakadaki “Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.” ve “Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

C) Mycoplasma pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae atipik pnömoni yapabilir ancak genellikle daha genç hastalarda ve su sistemi maruziyeti olmadan düşünülür. Bu olguda “Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.” ve “Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Chlamydia psittaci: Chlamydia psittaci kuş teması sonrası pnömoniyle ilişkilidir; bu olguda belirgin su aerosolü maruziyeti vardır. Bu olguda “Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.” ve “Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.” ipuçları tanısallık karar açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Klebsiella pneumoniae: Klebsiella pneumoniae alkol kullanım öyküsü olanlarda nekrotizan lobar pnömoni ve yoğun balgamla öne çıkabilir; verilen ipuçları Legionella lehinedir. Bu olguda “Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.” ve “Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.” ipuçları tanısallık karar açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Atipik pnömoni ve hiponatremi olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. “Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.” ve “Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.” birlikte okunduğunda Legionella pneumophila seçeneği öne çıkar; “Hiponatremi ve pozitif idrar antijen testi aynı etken lehine destek sağlar.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Otelde su sistemi maruziyeti, yüksek ateşli atipik pnömoni, ishal, baş ağrısı ve hiponatremi Legionella pneumophila enfeksiyonunu düşündürür. İdrar antijen testinin pozitifliği bu etken için tanısallık değeri yüksek bir bulgudur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.”, “Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.” ve “Hiponatremi ve pozitif idrar antijen testi aynı etken lehine destek sağlar.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Legionella pneumophila en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakın zamanda otel ve spa su sistemi maruziyeti vardır.

Kanıt 2: Pnömoniye ishal ve baş ağrısı eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Hiponatremi ve pozitif idrar antijen testi aynı etken lehine destek sağlar.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Legionella pnömonisinde su sistemi maruziyeti, gastrointestinal bulgular ve hiponatremi klasik sınav ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 84: v173-new-084-ates-ve-yaygin-lenfadenopati

Başlık: Ateş ve yaygın lenfadenopati

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik ve laboratuvar ipuçlarından etkeni belirleme.

Learning Target: Enfeksiyöz mononükleozda etken virüs ve laboratuvar bulgularını ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, boğaz ağrısı ve boyunda şişlik nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık bir haftadır halsizlik, yutma güçlüğü ve ateş tarifliyor. Son günlerde sol üst kadranda dolgunluk hissi olduğunu belirtiyor. Yakın zamanda antibiyotik kullanmamıştır.

Demografi: 18 yaşında erkek hasta | Setting: Aile hekimliği polikliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.7°C | Şok indeksi: 0,81

Fizik Muayene

- Tonsiller belirgin büyümüş ve eksüdatiftir.
- Posterior servikal lenf nodları bilateral büyümüştür.
- Dalak ucu palpabl olarak hissedilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lenfositoz saptandı. | Klinik anlam: Viral lenfoproliferatif yanıtı destekler. | Sonuç yorumu: Viral lenfoproliferatif yanıtı destekler. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Lenfositoz saptandı. | Yorum: Viral lenfoproliferatif yanıtı destekler. | Satırlar: Tam kan sayımı / 14500 /mm³ / 4500-11000 /mm³ | Viral lenfoproliferatif yanıtı destekler.

Tetkik 2: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Atipik lenfositler izlendi. | Klinik anlam: Reaktif T lenfosit yanıtını düşündürür. | Sonuç yorumu: Reaktif T lenfosit yanıtını düşündürür. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Atipik lenfositler izlendi. | Yorum: Reaktif T lenfosit yanıtını düşündürür. | Satırlar: Periferik yayma / Atipik lenfositler izlendi. // Reaktif T lenfosit yanıtını düşündürür.

Tetkik 3: Heterofil antikor testi

Etiket: Heterofil antikor testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Klinik tabloyla birlikte tanıyı destekler. | Sonuç yorumu: Klinik tabloyla birlikte tanıyı destekler. | Sonuç başlığı: Heterofil antikor testi | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Klinik tabloyla birlikte tanıyı destekler. | Satırlar: Heterofil antikor testi / Pozitif saptandı. // Klinik tabloyla birlikte tanıyı destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-050 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Atipik lenfositler izlendi. | Klinik anlam: Reaktif T lenfosit yanıtını düşündürür. | URL:

https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/050_050-atipik-lenfositler-periferik-yayma.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/050_050-atipik-lenfositler-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Atipik lenfositler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cytomegalovirus
- B) Human herpesvirus 6
- C) Epstein-Barr virus
- D) Adenovirus
- E) Parvovirus B19

Doğru Cevap: Epstein-Barr virus

A) Cytomegalovirus: Cytomegalovirus mononükleoz benzeri tablo yapabilir ancak heterofil antikor genellikle negatif beklenir. Bu olguda “Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.” ve “Splenomegali muayenede gösterilmiştir.” ipuçları tanısallık karar açısından Epstein-Barr virus seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Human herpesvirus 6: Human herpesvirus 6 roseola infantumla ilişkilidir; ergen hastadaki heterofil pozitif mononükleoz tablosunu en iyi açıklamaz. Bu olguda “Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.” ve “Splenomegali muayenede gösterilmiştir.” ipuçları tanısallık karar açısından Epstein-Barr virus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Epstein-Barr virus: Epstein-Barr virus heterofil antikor pozitifliği, atipik lenfositoz, farenjit, posterior servikal lenfadenopati ve splenomegaliyle en uyumlu etkindir. Vakadaki “Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.” ve “Splenomegali muayenede gösterilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

D) Adenovirus: Adenovirus farenjit ve konjonktivit yapabilir ancak splenomegali ve heterofil antikor pozitifliğiyle tipik mononükleoz tablosunu açıklamaz. Bu olguda “Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.” ve “Splenomegali muayenede gösterilmiştir.” ipuçları tanısallık karar açısından Epstein-Barr virus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Parvovirus B19: Parvovirus B19 eritema infeksiyozum ve aplastik krizle ilişkilidir; bu Vakadaki lenfoproliferatif tabloya uymaz. Bu olguda “Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.” ve “Splenomegali muayenede gösterilmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından Epstein-Barr virus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve yaygın lenfadenopati olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.” ve “Splenomegali muayenede gösterilmiştir.” birlikte okunduğunda Epstein-Barr virus seçeneği öne çıkar; “Periferik yaymada atipik lenfositler ve heterofil antikor pozitifliği saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, eksüdatif farenjit, posterior servikal lenfadenopati, splenomegali, atipik lenfositoz ve heterofil antikor pozitifliği enfeksiyöz mononükleozu düşündürür. Bu tablonun en tipik etkeni Epstein-Barr virus olup B lenfositleri enfekte eder ve reaktif T lenfosit yanıtı oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.”, “Splenomegali muayenede gösterilmiştir.” ve “Periferik yaymada atipik lenfositler ve heterofil antikor pozitifliği saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Epstein-Barr virus en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Eksüdatif farenjit ve posterior servikal lenfadenopati birlikte vardır.

Kanıt 2: Splenomegali muayenede gösterilmiştir.

Kanıt 3: Periferik yaymada atipik lenfositler ve heterofil antikor pozitifliği saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Enfeksiyöz mononükleozda posterior servikal lenfadenopati, atipik lenfosit ve heterofil antikor pozitifliği Epstein-Barr virus lehinedir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 85: v173-new-085-sigara-oykusu-olan-hastada-hiponatremi

Başlık: Sigara öyküsü olan hastada hiponatremi

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularıyla tanıya ulaşma.

Learning Target: Küçük hücreli akciğer karsinomunun paraneoplastik SIADH ve histolojik özelliklerini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kilo kaybı, öksürük ve son günlerde artan halsizlik nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık 45 paket-yıl sigara öyküsü vardır. Üç aydır iştahsızlık, kilo kaybı ve inatçı öksürük tarifliyor. Son haftada baş ağrısı ve konsantrasyon güçlüğü gelişmiştir.

Demografi: 64 yaşında erkek hasta | Setting: Göğüs hastalıkları polikliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 90/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,76

Fizik Muayene

- Hasta zayıf ve halsiz görünümündedir.
- Sağ supraklaviküler bölgede sert lenf nodu palpe edilir.
- Mukozalar nemlidir, belirgin periferik ödem yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Paraneoplastik su tutulumu açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Paraneoplastik su tutulumu açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Paraneoplastik su tutulumu açısından anlamlıdır. | Satırlar: Serum sodyum / 121 mmol/L / 135-145 mmol/L / Paraneoplastik su tutulumu açısından anlamlıdır.

Tetkik 2: Toraks bilgisayarlı tomografi

Etiket: Toraks bilgisayarlı tomografi | Tip: ct | Alt tip: BT | Özet: Sağ hiler bölgede santral yerleşimli kitle ve mediastinal lenfadenopatiler izlendi. | Klinik anlam: Santral akciğer tümörü olasılığını artırır. | Sonuç yorumu: Santral akciğer tümörü olasılığını artırır. | Sonuç başlığı: Toraks bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Sağ hiler bölgede santral yerleşimli kitle ve mediastinal lenfadenopatiler izlendi. | Yorum: Santral akciğer tümörü olasılığını artırır. | Satırlar: Toraks bilgisayarlı tomografi / Sağ hiler bölgede santral yerleşimli kitle ve mediastinal lenfadenopatiler izlendi. // Santral akciğer tümörü olasılığını artırır.

Tetkik 3: Biyopsi histopatolojisi

Etiket: Biyopsi histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler, nükleer molding ve yaygın nekroz izlendi. | Klinik anlam: Nöroendokrin özellikli agresif tümör paternini düşündürür. | Sonuç yorumu: Nöroendokrin özellikli agresif tümör paternini düşündürür. | Sonuç başlığı: Biyopsi histopatolojisi | Sonuç özeti: Dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler, nükleer molding ve yaygın nekroz izlendi. | Yorum: Nöroendokrin özellikli agresif tümör paternini düşündürür. | Satırlar: Biyopsi histopatolojisi / Dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler, nükleer molding ve yaygın nekroz izlendi. // Nöroendokrin özellikli agresif tümör paternini düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-051 | Başlık: Toraks bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Sağ hiler bölgede santral yerleşimli kitle ve mediastinal lenfadenopatiler izlendi. | Klinik anlam: Santral akciğer tümörü olasılığını artırır. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/051_051-santral-akciger-kitlesi-toraks-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/051_051-santral-akciger-kitlesi-toraks-bt.webp | Alt text: Toraks bilgisayarlı tomografi - Sağ hiler bölgede santral yerleşimli kitle ve mediastinal lenfadenopatiler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-052 | Başlık: Biyopsi histopatolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler, nükleer molding ve yaygın nekroz izlendi. | Klinik anlam: Nöroendokrin özellikli agresif tümör paternini düşündürür. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/052_052-kucuk-mavi-hucrel-tumor-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/052_052-kucuk-mavi-hucrel-tumor-histopatoloji.webp | Alt text: Biyopsi histopatolojisi - Dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler, nükleer molding ve yaygın nekroz izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adenokarsinom
B) Skuamöz hücreli karsinom
C) Küçük hücreli akciğer karsinomu
D) Mezotelyoma
E) Pulmoner hamartom

Doğru Cevap: Küçük hücreli akciğer karsinomu

A) Adenokarsinom: Adenokarsinom daha çok periferik yerleşim ve glandüler yapı ile ilişkilidir; bu olguda santral küçük mavi hücreli nöroendokrin patern ön plandadır. Bu olguda “Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.” ve “Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından Küçük hücreli akciğer karsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Skuamöz hücreli karsinom: Skuamöz hücreli karsinom santral yerleşebilir ancak keratinizasyon veya interselüler köprü bulguları beklenir; nükleer molding ve SIADH paterni küçük hücreli tümörü destekler. Bu olguda “Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.” ve “Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Küçük hücreli akciğer karsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Küçük hücreli akciğer karsinomu: Küçük hücreli akciğer karsinomu yoğun sigara öyküsü, santral kitle, nükleer molding ve hiponatremiyle bu olguda en olası tanıdır. Vakadaki “Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.” ve “Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

D) Mezotelyoma: Mezotelyoma plevral kaynaklı asbest ilişkili tümördür; hiler santral kitle ve küçük mavi hücreli biyopsi paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.” ve “Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Küçük hücreli akciğer karsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Pulmoner hamartom: Pulmoner hamartom benign lezyondur ve paraneoplastik hiponatremi ile agresif küçük hücreli histoloji beklenmez. Bu olguda “Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.” ve “Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Küçük hücreli akciğer karsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sigara öyküsü olan hastada hiponatremi olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.” ve “Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Küçük hücreli akciğer karsinomu seçeneği öne çıkar; “Biyopside dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler ve nükleer molding görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağır sigara öyküsü, santral-hiler kitle, mediastinal lenfadenopati, hiponatremiyle uyumlu paraneoplastik tablo ve biyopside küçük mavi hücreler ile nükleer molding küçük hücreli akciğer karsinomunu düşündürür. Bu tümör nöroendokrin özellik taşır ve uygunsuz antidiüretik hormon salınımı gibi paraneoplastik sendromlarla ilişkilidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.”, “Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.” ve “Biyopside dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler ve nükleer molding görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Küçük hücreli akciğer karsinomu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada uzun süreli yoğun sigara öyküsü vardır.

Kanıt 2: Toraks görüntülemesinde santral-hiler kitle ve mediastinal lenfadenopati izlenmiştir.

Kanıt 3: Biyopside dar sitoplazmalı küçük mavi hücreler ve nükleer molding görülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Küçük hücreli akciğer karsinomu santral yerleşir, sigarayla güçlü ilişkilidir ve SIADH gibi paraneoplastik sendromlar yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 86: v173-new-086-yasli-hastada-mekanik-obstruksiyon

Başlık: Yaşlı hastada mekanik obstrüksiyon

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularıyla tanıya ulaşma.

Learning Target: Safra taşı ileusu tanısında klinik ve radyolojik triadı ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, karın ağrısı, kusma ve gaz-gaita çıkaramama nedeniyle acile başvuruyor. Son iki gündür kramp tarzı karın ağrısı ve tekrarlayan kusmaları olduğunu belirtiyor. Uzun yıllardır safra kesesi taşı olduğu biliniyor ancak ameliyat olmamıştır. Ateş veya belirgin sarılık tariflemiyor.

Demografi: 78 yaşında kadın hasta | Setting: Acil serviste genel cerrahi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.4°C | Şok indeksi: 0,93 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Batın distandüdü ve barsak sesleri yüksek tınılır.
- Yaygın hassasiyet vardır ancak belirgin defans yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Abdominal bilgisayarlı tomografi

Etiket: Abdominal bilgisayarlı tomografi | Tip: ct | Alt tip: BT | Özet: İnce bağırsakta obstrüksiyon, safra yollarında hava ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş ile uyumlu görünüm izlendi. | Klinik anam: Mekanik obstrüksiyonun nedenini gösterir. | Sonuç yorumu: Mekanik obstrüksiyonun nedenini gösterir. | Sonuç başlığı: Abdominal bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: İnce bağırsakta obstrüksiyon, safra yollarında hava ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş ile uyumlu görünüm izlendi. | Yorum: Mekanik obstrüksiyonun nedenini gösterir. | Satırlar: Abdominal bilgisayarlı tomografi / İnce bağırsakta obstrüksiyon, safra yollarında hava ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş ile uyumlu görünüm izlendi. // Mekanik obstrüksiyonun nedenini gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-053 | Başlık: Abdominal bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: İnce bağırsakta obstrüksiyon, safra yollarında hava ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş ile uyumlu görünüm izlendi. | Klinik anam: Mekanik obstrüksiyonun nedenini gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/053_053-gallstone-ileus-abdominal-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/053_053-gallstone-ileus-abdominal-bt.webp | Alt text: Abdominal bilgisayarlı tomografi - İnce bağırsakta obstrüksiyon, safra yollarında hava ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş ile uyumlu görünüm izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Safra taşı ileusu
B) Akut pankreatit
C) Akut kolanjit
D) Paralitik ileus
E) İskemik kolit

Doğru Cevap: Safra taşı ileusu

A) Safra taşı ileusu: Safra taşı ileusu safra taşı öyküsü, mekanik obstrüksiyon, pnömobili ve ektopik taş bulgularıyla bu olguda en olası tanıdır. Vakadaki “Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.” ve “Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Akut pankreatit: Akut pankreatitte epigastrik ağrı ve pankreatik enzim yüksekliği beklenir; BT’de ektopik taşlı bağırsak obstrüksiyonu bu tanıyı desteklemez. Bu olguda “Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.” ve “Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.” ipuçları tanısız karar açısından Safra taşı ileusu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Akut kolanjit: Akut kolanjitte ateş, sağ üst kadranda ağrısı ve sarılık beklenir; bu olguda mekanik ince bağırsak obstrüksiyonu belirleyicidir. Bu olguda “Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.” ve “Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.” ipuçları tanısız karar açısından Safra taşı ileusu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Paralişik ileus: Paralişik ileusta mekanik tıkanıklık yapan ektopik taş beklenmez; BT bulguları mekanik obstrüksiyonu göstermektedir. Bu olguda “Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.” ve “Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.” ipuçları tanısız karar açısından Safra taşı ileusu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) İskemik kolit: İskemik kolit genellikle karın ağrısı ve kanlı dışkı ile seyredir; pnömobili ve distal ileum taşı bu tanıyı açıklamaz. Bu olguda “Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.” ve “Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.” ipuçları tanısız karar açısından Safra taşı ileusu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekeç / Kanıt / Core

Klinik gerekeç: Yaşlı hastada mekanik obstrüksiyon olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.” ve “Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.” birlikte okunduğunda Safra taşı ileusu seçeneği öne çıkar; “BT’de pnömobili ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı hastada safra taşı öyküsü, mekanik ince bağırsak obstrüksiyonu, pnömobili ve ektopik intestinal taş safra taşı ileusunu düşündürür. Bu tablo genellikle kronik inflamasyon sonucu gelişen kolesistoenterik fistülden geçen büyük taşın distal ileumda tıkanıklık oluşturmaya meydana gelir. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.”, “Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.” ve “BT’de pnömobili ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Safra taşı ileusu en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada uzun süredir bilinen safra taşı öyküsü vardır.

Kanıt 2: Gaz-gaita çıkaramama, kusma ve distansiyon mekanik obstrüksiyonu düşündürür.

Kanıt 3: BT’de pnömobili ve distal ileumda ektopik kalsifiye taş izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Safra taşı ileusunda Rigler triadı: ince bağırsak obstrüksiyonu, pnömobili ve ektopik safra taşıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 87: v173-new-087-kapali-ortamda-bas-agrisi-ve-bilinc-bulanikligi

Başlık: Kapalı ortamda baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik bulguları temel mekanizma ile ilişkilendirme.

Learning Target: Karbonmonoksit zehirlenmesinde oksijen-hemoglobin eğrisi değişimini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, baş ağrısı, bulantı ve sersemlik nedeniyle acile getiriliyor. Kış günü kapalı garajda çalışan jeneratör yanında yaklaşık bir saat kaldığı öğreniliyor. Aynı ortamda bulunan başka bir kişide de baş ağrısı gelişmiştir. Nefes darlığı hafiftir.

Demografi: 35 yaşında erkek hasta | Setting: Acil serviste

Vital Bulgular

Kan basıncı: 124/76 mmHg | Nabız: 106/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,85

Fizik Muayene

- Hasta uykuya eğilimli ancak uyandırılabilir durumdadır.
- Cilt rengi normal görünümündedir.
- Akciğer sesleri doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı ko-oksimetri

Etiket: Arter kan gazı ko-oksimetri | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Karboksihemoglobin düzeyi belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Karbonmonoksit maruziyetini destekler. | Sonuç yorumu: Karbonmonoksit maruziyetini destekler. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı ko-oksimetri | Sonuç özeti: Karboksihemoglobin düzeyi belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Karbonmonoksit maruziyetini destekler. | Satırlar: Arter kan gazı ko-oksimetri / 28 % / <3% sigara içmeyenlerde / Karbonmonoksit maruziyetini destekler.

Tetkik 2: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Doku hipoksisini düşündürür. | Sonuç yorumu: Doku hipoksisini düşündürür. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Doku hipoksisini düşündürür. | Satırlar: Serum laktat / 4.6 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L / Doku hipoksisini düşündürür.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki doku hipoksisinin temel fizyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hemoglobinin oksijene afinitesinin azalması ve eğrinin sağa kayması
- B) Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması
- C) Alveollerde surfaktan azalmasına bağlı yaygın atelektazi gelişmesi
- D) Pulmoner kapiller hidrostatik basınç artışıyla alveoler ödem oluşması
- E) Methemoglobin oluşumuyla demirin ferrik formda kalıcı oksitlenmesi

Doğru Cevap: Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması

A) Hemoglobinin oksijene afinitesinin azalması ve eğrinin sağa kayması: Hemoglobinin oksijene afinitesinin azalması ve eğrinin sağa kayması dokulara oksijen bırakılmasını artırır; karbonmonoksit zehirlenmesindeki mekanizma bunun tersidir. Bu olguda “Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.” ve “Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması: Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bölgelerde oksijen afinitesinin artması karbonmonoksit zehirlenmesindeki doku hipoksisini açıklar. Vakadaki “Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.” ve “Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Alveollerde surfaktan azalmasına bağlı yaygın ateletaksi gelişmesi: Surfactan azalmasına bağlı ateletaksi yenidoğan solunum sıkıntısı gibi durumlarda beklenir; bu olguda temel sorun hemoglobin bağlanmasındır. Bu olguda “Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.” ve “Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pulmoner kapiller hidrostatik basınç artışıyla alveoler ödem oluşması: Pulmoner kapiller basınç artışı kardiyogenik pulmoner ödem mekanizmasıdır; normal akciğer muayenesi ve yüksek karboksihemoglobin bu seçeneği geri plana iter. Bu olguda “Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.” ve “Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Methemoglobin oluşumuyla demirin ferrik formda kalıcı oksitlenmesi: Methemoglobin oluşumu nitrit veya oksidan ilaç maruziyetlerinde ferrik demir artışıyla ilişkilidir; burada karboksihemoglobin artışı belirleyicidir. Bu olguda “Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.” ve “Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kapalı ortamda baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.” ve “Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması seçeneği öne çıkar; “Karboksihemoglobin ve laktat düzeyleri yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kapalı ortamda jeneratör maruziyeti, normal pulse oksimetreye rağmen nörolojik bulgular ve yüksek karboksihemoglobin karbonmonoksit zehirlenmesini gösterir. Karbonmonoksit hemoglobine yüksek afiniteli bağlanarak oksijen taşıma kapasitesini azaltır ve kalan oksijen bağlanma bölgelerinin afinitesini artırarak oksijen-hemoglobin ayrışma eğrisini sola kaydırır; dokulara oksijen bırakılması azalır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.”, “Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.” ve “Karboksihemoglobin ve laktat düzeyleri yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesinin azalması ve kalan bağlanma bölgelerinde oksijen afinitesinin artması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kapalı garajda çalışan jeneratör maruziyeti vardır.

Kanıt 2: Pulse oksimetre normal görünmesine rağmen bilinç bulanıklığı gelişmiştir.

Kanıt 3: Karboksihemoglobin ve laktat düzeyleri yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Karbonmonoksit zehirlenmesinde pulse oksimetre yanıltıcı olabilir; eğri sola kayar ve dokulara oksijen bırakılması azalır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 88: v173-new-088-norolojik-bulgular-ve-laktik-asidoz

Başlık: Nörolojik bulgular ve laktik asidoz

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik bulguları temel mekanizma ile ilişkilendirme.

Learning Target: Pirüvat dehidrogenaz eksikliğinde metabolik blok ve tedavi mantığını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, gelişim geriliği, hipotoni ve tekrarlayan laktik asidoz atakları nedeniyle getiriliyor. Aile, bebeğin baş kontrolünün yaşıtlarına göre geciktiğini ve enfeksiyon dönemlerinde soluklaşma ile hızlı soluma atakları yaşadığını belirtiyor. Beslenme güçlüğü vardır ancak belirgin ishal tariflenmiyor.

Demografi: 9 aylık erkek bebek | Setting: Çocuk metabolizma kliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 136/dk | Solunum: 38/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,45 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek hipotoniktir ve çevreyle ilgisi azalmıştır.
- Karaciğer belirgin büyümemiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Pirüvatın alternatif yola yöneldiğini düşündürür. | Sonuç yorumu: Pirüvatın alternatif yola yöneldiğini düşündürür. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Pirüvatın alternatif yola yöneldiğini düşündürür. | Satırlar: Serum laktat / 7.4 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L / Pirüvatın alternatif yola yöneldiğini düşündürür.

Tetkik 2: Serum alanin

Etiket: Serum alanin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Pirüvat birikimini destekleyen metabolik bulgudur. | Sonuç yorumu: Pirüvat birikimini destekleyen metabolik bulgudur. | Sonuç başlığı: Serum alanin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Pirüvat birikimini destekleyen metabolik bulgudur. | Satırlar: Serum alanin / Yüksek saptandı. // Pirüvat birikimini destekleyen metabolik bulgudur.

Tetkik 3: Enzim analizi

Etiket: Enzim analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pirüvat dehidrogenaz kompleksi aktivitesi düşük saptandı. | Klinik anlam: Mitokondriyal enerji üretim basamağında blok olduğunu gösterir. | Sonuç yorumu: Mitokondriyal enerji üretim basamağında blok olduğunu gösterir. | Sonuç başlığı: Enzim analizi | Sonuç özeti: Pirüvat dehidrogenaz kompleksi aktivitesi düşük saptandı. // Mitokondriyal enerji üretim basamağında blok olduğunu gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki laktik asidozun temel biyokimyasal mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi
- Glukoz-6-fosfatın serbest glukozla dönüşmemesi nedeniyle karaciğerde glikojen birikmesi
- Fenilalaninin tirozine hidroksillenememesi nedeniyle fenilketonların artması
- Yağ asitlerinin mitokondriye taşınamaması nedeniyle ketogenez artışı
- Homogentisik asidin parçalanamaması nedeniyle bağ dokusunda pigment birikmesi

Doğru Cevap: Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi

A) Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi: Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi pirüvat birikimine ve laktat-alanin üretimine yönelme neden olarak bu laktik asidoz tablosunu açıklar. Vakadaki "Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Glukoz-6-fosfatın serbest glukozla dönüşmemesi nedeniyle karaciğerde glikojen birikmesi: Glukoz-6-fosfatın serbest glukozla dönüşmemesi Von Gierke hastalığı mekanizmasıdır; burada enzim analizi pirüvat dehidrogenaz blokunu göstermektedir. Bu olguda "Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Fenilalaninin tirozine hidroksillenmemesi nedeniyle fenilketonların artması: Fenilalaninin tirozine dönüşmemesi fenilketonüriye yol açar; laktat ve alanin yüksekliğini açıklamaz. Bu olguda "Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Yağ asitlerinin mitokondriye taşınamaması nedeniyle ketogenez artışı: Yağ asitlerinin mitokondriye taşınamaması karnitin döngüsü bozukluklarını düşündürür; bu hastada temel blok pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşümündedir. Bu olguda "Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Homogentisik asidin parçalanamaması nedeniyle bağ dokusunda pigment birikmesi: Homogentisik asit parçalanma kusuru alkaptonüriyle ilişkilidir; nörolojik laktik asidoz ve pirüvat dehidrogenaz düşüklüğünü açıklamaz. Bu olguda "Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Nörolojik bulgular ve laktik asidoz olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir." birlikte okunduğunda Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi seçeneği öne çıkar; "Pirüvat dehidrogenaz kompleksi aktivitesi düşük saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Pirüvat dehidrogenaz kompleksi pirüvatı asetil-CoA'ya dönüştürerek karbonhidrat metabolizmasını sitrik asit döngüsüne bağlar. Bu enzim aktivitesi azaldığında pirüvat mitokondriyal oksidasyona giremez ve laktat ile alanin üretimine yönelir; özellikle sinir sistemi enerji yetersizliğinden etkilenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır.", "Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir." ve "Pirüvat dehidrogenaz kompleksi aktivitesi düşük saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat ve alanin üretimine yönelmesi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Bebekte gelişim geriliği ve hipotoni vardır.

Kanıt 2: Serum laktat ve alanin düzeyleri yüksektir.

Kanıt 3: Pirüvat dehidrogenaz kompleksi aktivitesi düşük saptanmıştır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Pirüvat dehidrogenaz eksikliğinde karbonhidrat yükü laktik asidozu artırabilir; yağdan zengin ketojenik yaklaşım enerji metabolizmasını destekleyebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 89: v173-new-089-gece-artan-el-uyusmasi

Başlık: Gece artan el uyuşması

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik bulguyu ilgili anatomik yapı ile ilişkilendirme.

Learning Target: Karpal tünel sendromunda median sinir basısını duyuşsal ve motor bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ elde gece artan uyuşma ve kavrama güçlüğü nedeniyle başvuruyor. Yakınmalarının özellikle gece ve uzun süre bilgisayar kullandıktan sonra arttığını, başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta karıncalanma hissettiğini belirtiyor. Boyun ağrısı veya travma öyküsü yoktur.

Demografi: 46 yaşında kadın hasta | Setting: Nöroloji polikliniğinde

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ elde tenar bölgede hafif atrofi ve başparmak opozisyonunda güçsüzlük vardır.
- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısında duyu azalması izlenir.
- Avuç içi tenar deri duysusu belirgin korunmuştur.
- Tinel testi el bileğinde pozitif.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Sinir iletim çalışması

Etiket: Sinir iletim çalışması | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: El bileği düzeyinde median sinir duyuşsal ve motor iletiminde yavaşlama saptandı. | Klinik anlam: Kompresyon düzeyini destekler. | Sonuç yorumu: Kompresyon düzeyini destekler. | Sonuç başlığı: Sinir iletim çalışması | Sonuç özeti: El bileği düzeyinde median sinir duyuşsal ve motor iletiminde yavaşlama saptandı. | Yorum: Kompresyon düzeyini destekler. | Satırlar: Sinir iletim çalışması / El bileği düzeyinde median sinir duyuşsal ve motor iletiminde yavaşlama saptandı. / / Kompresyon düzeyini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-273 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Avuç içi tenar deri duysusu belirgin korunmuştur. | Klinik anlam: Nervus medianus | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/273_clinical_hand_examination_with_swab.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/273_clinical_hand_examination_with_swab.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Avuç içi tenar deri duysusu belirgin korunmuştur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada bası altında kalan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus ulnaris
- B) Nervus radialis
- C) Nervus medianus
- D) Nervus musculocutaneus
- E) Nervus axillaris

Doğru Cevap: Nervus medianus

A) Nervus ulnaris: Nervus ulnaris küçük parmak ve yüzük parmağının ulnar yarısı ile interosseöz kasları etkiler; bu Vakadaki radial üç buçuk parmak paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.” ve “Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nervus radialis: Nervus radialis el bileği ekstansiyonu ve dorsal radial el duyusuyla ilişkilidir; tenar opozisyon güçsüzlüğünü açıklamaz. Bu olguda “Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.” ve “Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus medianus: Nervus medianus karpal tünelde bası altında kalır ve radial üç buçuk parmak duyusu ile tenar motor fonksiyon kaybını açıklar. Vakadaki “Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.” ve “Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekçidir.

D) Nervus musculocutaneus: Nervus musculocutaneus ön kol fleksörleri ve lateral ön kol duyusuyla ilişkilidir; el bileği düzeyindeki parmak uyuşmasını açıklamaz. Bu olguda “Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.” ve “Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus axillaris: Nervus axillaris deltoid kası ve lateral omuz duyusuyla ilişkilidir; el bileği kompresyon bulgularıyla bağlantılı değildir. Bu olguda “Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.” ve “Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gece artan el uyuşması olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.” ve “Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.” birlikte okunduğunda Nervus medianus seçeneği öne çıkar; “Sinir iletim çalışması el bileği düzeyinde median sinir etkilenmesini göstermiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gece artan parestezi, radial üç buçuk parmakta duyu azalması, tenar atrofi, başparmak opozisyon güçsüzlüğü ve el bileğinde Tinel pozitifliği karpal tünel sendromunu düşündürür. Karpal tünelde bası altında kalan yapı nervus medianustur; palmar kutanöz dal tünele girmeden ayrıldığı için tenar deri duyusu korunabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.”, “Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.” ve “Sinir iletim çalışması el bileği düzeyinde median sinir etkilenmesini göstermiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus medianus en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Uyuşma başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının radial yarısındadır.

Kanıt 2: Tenar atrofi ve başparmak opozisyon güçsüzlüğü vardır.

Kanıt 3: Sinir iletim çalışması el bileği düzeyinde median sinir etkilenmesini göstermiştir.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanması yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguyla uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Karpal tünel sendromunda nervus medianus etkilenir; palmar kutanöz dal tünel dışında seyrettiği için tenar deri duyusu korunabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 90: v173-new-090-solunum-depresyonu-ve-miyozis

Başlık: Solunum depresyonu ve miyozis

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Opioid toksisitesinde antidot ve reseptör düzeyindeki etkiyi belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, evinde bilinç bulanıklığı ve yavaş solunumla bulunduğu için acile getiriliyor. Yakınları hastanın kronik bel ağrısı nedeniyle reçeteli ağrı kesici kullandığını, son günlerde dozunu artırdığını belirtiyor. Alkol alımı net değildir. Travma öyküsü yoktur.

Demografi: 28 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servise bilinç değişikliğiyle getiriliyor.

Vital Bulgular

Kan basıncı: 98/62 mmHg | Nabız: 58/dk | Solunum: 7/dk | SpO₂: %84% | Ateş: 36.6°C | Şok indeksi: 0,59

Fizik Muayene

- Hasta somnolandır ve ağırlı uyarılarla uyanmaktadır.
- Pupiller bilateral belirgin miyotiktir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Hipoglisemiye bağlı bilinç değişikliği geri plandadır. | Sonuç yorumu: Hipoglisemiye bağlı bilinç değişikliği geri plandadır. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Hipoglisemiye bağlı bilinç değişikliği geri plandadır. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / 104 mg/dL / 70-140 mg/dL / Hipoglisemiye bağlı bilinç değişikliği geri plandadır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada solunum depresyonunu hızla geri çevirmek için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Flumazenil
- B) Nalokson
- C) Atropin
- D) Fomepizol
- E) Pralidoksim

Doğru Cevap: Nalokson

A) Flumazenil: Flumazenil benzodiazepin etkilerini geri çevirebilir ancak opioid reseptörlerini antagonize etmez ve bu miyozisli solunum depresyonu tablosunda uygun ilk antidot değildir. Bu olguda “Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.” ve “Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nalokson: Nalokson opioid reseptörlerine kompetitif antagonizma yaparak opioid kaynaklı solunum depresyonunu hızla geri çevirebilir. Vakadaki “Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.” ve “Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekçidir.

C) Atropin: Atropin muskarinik reseptör antagonisti olarak bradikardi veya kolinerjik bulgular için kullanılabilir; opioid toksisitesinin temel mekanizmasını düzeltmez. Bu olguda “Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.” ve “Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

kılar.

D) Fomepizol: Fomepizol metanol ve etilen glikol zehirlenmelerinde alkol dehidrogenazı inhibe eder; miyozisli opioid toksisitesinde yeri yoktur. Bu olguda “Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.” ve “Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Pralidoksim: Pralidoksim organofosfat zehirlenmesinde asetilkolinesterazı yeniden aktive eder; opioid reseptör aracılı solunum depresyonunu tedavi etmez. Bu olguda “Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.” ve “Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Nalokson seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Solunum depresyonu ve miyozis olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.” ve “Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.” birlikte okunduğunda Nalokson seçeneği öne çıkar; “Solunum sayısı düşük ve oksijen satürasyonu azalmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bilinç değişikliği, belirgin miyozis ve solunum depresyonu opioid toksisitesi için klasik triaddir. Nalokson opioid reseptörlerinde kompetitif antagonist olarak etki eder ve solunum depresyonunu hızla geri çevirebilir; havayolu ve ventilasyon desteği de eş zamanlı sağlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.”, “Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.” ve “Solunum sayısı düşük ve oksijen satürasyonu azalmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nalokson en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastanın reçeteli ağrı kesici dozunu artırdığı öğrenilmiştir.

Kanıt 2: Somnolans ve bilateral belirgin miyozis vardır.

Kanıt 3: Solunum sayısı düşük ve oksijen satürasyonu azalmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Opioid toksisitesinde hayatı tehdit eden bulgu solunum depresyonudur; antidot naloksondur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 91: v174-new-091-yenidoganda-surekli-ufurum

Başlık: Yenidoğanda sürekli üfürüm

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Patent duktus arteriozusun fetal dolaşım ve doğum sonrası kapanma fizyolojisiyle ilişkisini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme sırasında çabuk yorulma ve muayenede duyulan üfürüm nedeniyle yönlendiriliyor. Prematüre doğduğu, doğumdan sonra birkaç gün oksijen desteği aldığı ve son günlerde emerken terleme ile çabuk yorulma geliştiği öğreniliyor. Morarma tariflenmiyor. Demografi: 12 günlük kız bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 156/dk | Solunum: 58/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,23 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek takipneik görünümündedir.
- Sol infraklaviküler alanda sürekli makine tarzında üfürüm duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Aort ile pulmoner arter arasında devam eden damar açıklığı ve soldan sağa şant izlendi. | Klinik anlam: Fetal damar kalıntısının doğum sonrası kapanmadığını gösterir. | Sonuç yorumu: Fetal damar kalıntısının doğum sonrası kapanmadığını gösterir. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Aort ile pulmoner arter arasında devam eden damar açıklığı ve soldan sağa şant izlendi. | Yorum: Fetal damar kalıntısının doğum sonrası kapanmadığını gösterir. | Satırlar: Ekokardiyografi / Aort ile pulmoner arter arasında devam eden damar açıklığı ve soldan sağa şant izlendi. // Fetal damar kalıntısının doğum sonrası kapanmadığını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-054 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Aort ile pulmoner arter arasında devam eden damar açıklığı ve soldan sağa şant izlendi. | Klinik anlam: Fetal damar kalıntısının doğum sonrası kapanmadığını gösterir. | URL: https://iukbtlkzicqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/054_054-patent-dukus-arteriozus-ekokardiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzicqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/054_054-patent-dukus-arteriozus-ekokardiyografi.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Aort ile pulmoner arter arasında devam eden damar açıklığı ve soldan sağa şant izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki damar açıklığının doğum sonrası fizyolojik olarak kapanmasını sağlayan temel değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prostaglandin E2 düzeyinin artması ve oksijen basıncının azalması
- B) Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması
- C) Umbilikal ven basıncının artması
- D) Pulmoner vasküler direncin artması
- E) Foramen ovaleden sağdan sola şantın artması

Doğru Cevap: Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması

A) Prostaglandin E2 düzeyinin artması ve oksijen basıncının azalması: Prostaglandin E2 artışı ve oksijen basıncının azalması duktus arteriozusun açık kalmasını destekler, fizyolojik kapanmayı sağlamaz. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması: Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması duktus arteriozus düz kasını kasarak doğum sonrası kapanmayı başlatır. Vakadaki “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

C) Umbilikal ven basıncının artması: Umbilikal ven basıncının artması doğum sonrası beklenen temel değişiklik değildir ve duktus arteriozus kapanmasının ana mekanizmasını açıklamaz. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pulmoner vasküler direncin artması: Pulmoner vasküler direncin artması fetal dolaşımda sağdan sola akımı sürdürür; doğum sonrası direnc azalır. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Foramen ovaleden sağdan sola şantın artması: Foramen ovaleden sağdan sola şantın artması normal doğum sonrası dolaşım değişikliği değildir ve bu damar açıklığının kapanmasını açıklamaz. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda sürekli üfürüm olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması seçeneği öne çıkar; “Ekokardiyografide aort ile pulmoner arter arasında soldan sağa şant gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Doğumdan sonra akciğerlerin havalanmasıyla arteriyel oksijen basıncı artar ve plasenta kaynaklı prostaglandin E2 etkisi azalır. Bu değişiklikler duktus arteriozus düz kasında konstriksiyon oluşturarak fonksiyonel kapanmayı başlatır; prematüritede kapanma gecikebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek prematüre doğmuştur.”, “Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.” ve “Ekokardiyografide aort ile pulmoner arter arasında soldan sağa şant gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oksijen basıncının artması ve prostaglandin E2 etkisinin azalması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebek prematüre doğmuştur.

Kanıt 2: Sürekli makine tarzı üfürüm ve geniş nabız basıncı saptanmıştır.

Kanıt 3: Ekokardiyografide aort ile pulmoner arter arasında soldan sağa şant gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Duktus arteriozus doğum sonrası yüksek oksijen ve azalan prostaglandin E2 etkisiyle kapanır; prostaglandinler açıklığı sürdürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 92: v174-new-092-yenidoganda-safrali-kusma

Başlık: Yenidoğanda safralı kusma

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Fizyolojik umbilikal herniasyon ve rotasyon kusurunu klinik sonuçla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, safralı kusma ve karın distansiyonu nedeniyle acile getiriliyor. Doğumdan sonra ilk günlerde beslendiği ancak son 24 saatte beslenme sonrası yeşil renkli kusmalarının başladığı öğreniliyor. Mekonyum çıkışı olmuştur ancak sonrasında dışkılama azalmıştır.

Demografi: 6 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirmesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 162/dk | Solunum: 46/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,84 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek huzursuzdur ve batını hafif distandüdür.
- Dehidratasyon bulguları vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Üst gastrointestinal kontrastlı grafi

Etiket: Üst gastrointestinal kontrastlı grafi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı ve tirbuşon benzeri görünüm izlendiği bildirildi. | Klinik anlam: Midgut rotasyon bozukluğu ve volvulus riskini destekler. | Sonuç yorumu: Midgut rotasyon bozukluğu ve volvulus riskini destekler. | Sonuç başlığı: Üst gastrointestinal kontrastlı grafi | Sonuç özeti: Duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı ve tirbuşon benzeri görünüm izlendiği bildirildi. | Yorum: Midgut rotasyon bozukluğu ve volvulus riskini destekler. | Satırlar: Üst gastrointestinal kontrastlı grafi / Duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı ve tirbuşon benzeri görünüm izlendiği bildirildi. / / Midgut rotasyon bozukluğu ve volvulus riskini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-055 | Başlık: Üst gastrointestinal kontrastlı grafi | Modalite: xray | Bulgu: Duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı ve tirbuşon benzeri görünüm izlendiği bildirildi. | Klinik anlam: Midgut rotasyon bozukluğu ve volvulus riskini destekler. | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/055_055-intestinal-malrotasyon-ust-gis-kontrastli-grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/055_055-intestinal-malrotasyon-ust-gis-kontrastli-grafi.webp | Alt text: Üst gastrointestinal kontrastlı grafi - Duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı ve tirbuşon benzeri görünüm izlendiği bildirildi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki tablonun temel embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması
- B) Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılamaması
- C) Nöral krest hücrelerinin rektuma göç edememesi
- D) Ürakuş lümeninin doğum sonrası açık kalması
- E) Müller kanallarının orta hatta füzyon yapamaması

Doğru Cevap: Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması

A) Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması: Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması malrotasyon ve volvulus riskini açıklayan temel embriyolojik mekanizmadır. Vakadaki “Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.” ve “Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılamaması: Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayrılamaması trakeoözofageal fistül ile ilişkilidir; bu olguda safralı kusma ve malrotasyon bulgusu vardır. Bu olguda “Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.” ve “Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nöral krest hücrelerinin rektuma göç edememesi: Nöral krest hücrelerinin rektuma göç edememesi Hirschsprung hastalığına yol açar; kontrastlı grafideki duodenojejunal yerleşim bozukluğunu açıklamaz. Bu olguda “Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.” ve “Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Ürakuş lümeninin doğum sonrası açık kalması: Ürakuş lümeninin açık kalması umbilikustan idrar gelmesiyle ilişkilidir; bağırsak rotasyon kusuru oluşturmaz. Bu olguda “Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.” ve “Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Müller kanallarının orta hatta füzyon yapamaması: Müller kanallarının füzyon kusuru uterin anomalilere neden olur; erkek yenidoğanda safralı kusma tablosuyla ilişkili değildir. Bu olguda “Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.” ve “Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda safralı kusma olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.” ve “Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.” birlikte okunduğunda

Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması seçeneği öne çıkar; “Kontrastlı grafide duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda safralı kusma ve üst gastrointestinal grafide duodenojejunal bileşkenin anormal yerleşimi midgut malrotasyonunu düşündürür. Normalde midgut fizyolojik herniasyon sırasında ve karın boşluğuna dönerken superior mezenterik arter etrafında toplam 270 derece saat yönünün tersine rotasyon yapar; bu süreç tamamlanmazsa volvulus riski gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.”, “Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.” ve “Kontrastlı grafide duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Midgutun superior mezenterik arter etrafında normal rotasyonunu tamamlayamaması en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Bebekte doğumdan sonraki ilk günlerde safralı kusma başlamıştır.

Kanıt 2: Karın distansiyonu ve dışkılamada azalma obstrüktif süreci düşündürür.

Kanıt 3: Kontrastlı grafide duodenojejunal bileşkenin normal yerinde olmadığı gösterilmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Yenidoğanda safralı kusma aksi kanıtlanana kadar cerrahi acildir; malrotasyon-volvulus mutlaka düşünülmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 93: v174-new-093-travma-sonrasi-karin-hassasiyeti

Başlık: Travma sonrası karın hassasiyeti

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Künt karın travmasında hemodinamik instabilite varlığında uygun cerrahi yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, karın ağrısı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle travma odasına alınıyor. Yüksek hızlı araç içi trafik kazasında emniyet kemeri kullandığı, olay yerinde kısa süreli bilinç bulanıklığı olduğu öğreniliyor. Hastanın karın ağrısının giderek arttığı belirtiliyor.

Demografi: 32 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 78/46 mmHg | Nabız: 138/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %94% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,77 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk, terli ve huzursuzdur.
- Batında yaygın hassasiyet ve defans vardır.
- Pelvis stabil görünmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: FAST ultrasonografi

Etiket: FAST ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlendi. | Klinik anlam: İntraabdominal kanama olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: İntraabdominal kanama olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: FAST ultrasonografi | Sonuç özeti: Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlendi. | Yorum: İntraabdominal kanama olasılığını destekler. | Satırlar: FAST ultrasonografi / Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlendi. / İntraabdominal kanama olasılığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-056 | Başlık: FAST ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlendi. | Klinik anlam: İntraabdominal kanama olasılığını destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/056_056-fast-pozitif-serbest-sivi-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/056_056-fast-pozitif-serbest-sivi-ultrasonografi.webp | Alt text: FAST ultrasonografi - Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografi için izlem planlanması
- B) Acil eksploratif laparotomi yapılması
- C) Ayaktan analjezik tedavi ve yakın kontrol planlamak
- D) Elektif tanısal laparoskopi randevusu verilmesi
- E) Seri fizik muayene ile izlenmesi

Doğru Cevap: Acil eksploratif laparotomi yapılması

A) Kontrastlı abdominal bilgisayarlı tomografi için izlem planlanması: Vakadaki Hasta künt karın travması geçirmiştir ve Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir. Bu olguda “Hasta künt karın travması geçirmiştir.” ve “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eksploratif laparotomi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Acil eksploratif laparotomi yapılması: Acil eksploratif laparotomi instabil ve FAST pozitif travma hastasında kanama kontrolü için en uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Hasta künt karın travması geçirmiştir.” ve “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Ayaktan analjezik tedavi ve yakın kontrol planlamak: Vakadaki Hasta künt karın travması geçirmiştir ve Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir. Bu olguda “Hasta künt karın travması geçirmiştir.” ve “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eksploratif laparotomi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Elektif tanısal laparoskopi randevusu verilmesi: Elektif tanısal laparoskopi randevusu akut hemodinamik instabilite varlığında uygun değildir ve tedaviyi geciktirir. Bu olguda “Hasta künt karın travması geçirmiştir.” ve “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eksploratif laparotomi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Seri fizik muayene ile izlenmesi: Vakadaki Hasta künt karın travması geçirmiştir ve Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir. Bu olguda “Hasta künt karın travması geçirmiştir.” ve “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eksploratif laparotomi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Travma sonrası karın hassasiyeti olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta künt karın travması geçirmiştir.” ve “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.” birlikte okunduğunda Acil eksploratif laparotomi yapılması seçeneği öne çıkar; “FAST incelemede Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Künt karın travması sonrası hipotansiyon, taşikardi, periton bulguları ve FAST pozitifliği hemodinamik instabiliteyle birlikte intraabdominal kanamayı düşündürür. Stabil olmayan hastada bilgisayarlı tomografi için beklemek uygun değildir; kanama kontrolü için acil eksploratif laparotomi gerekir. Bu olguda

kararın temel ayrımı, “Hasta künt karın travması geçirmiştir.”, “Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.” ve “FAST incelemede Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil eksploratif laparotomi yapılması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hasta künt karın travması geçirmiştir.

Kanıt 2: Hipotansiyon ve taşikardi hemodinamik instabiliteyi göstermektedir.

Kanıt 3: FAST incelemede Morrison boşluğu ve pelviste serbest sıvı izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Künt travmada instabil hasta ve pozitif FAST varsa bilgisayarlı tomografi değil acil laparotomi düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 94: v174-new-094-sag-ust-kadran-agrisi

Başlık: Sağ üst kadran ağrısı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Akut kolesistitte klinik ve görüntüleme bulgularıyla uygun tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ üst kadranda başlayan ve sırtta yayılan karın ağrısı nedeniyle başvuruyor. Ağrının yağlı bir öğünden birkaç saat sonra başladığını, bulantı ve kusmanın eşlik ettiğini belirtiyor. Daha önce benzer ama daha kısa süren ağrı atakları olduğunu ifade ediyor.

Demografi: 46 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 122/76 mmHg | Nabız: 106/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,87

Fizik Muayene

● Sağ üst kadranda belirgin hassasiyet vardır ve derin inspirasyon sırasında palpasyonla ağrı nedeniyle inspirasyon kesilmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut inflamasyonu destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 15400 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Akut inflamasyonu destekler.

Tetkik 2: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Klinik anlam: Safra kesesi inflamasyonu lehine bulgular içerir. | Sonuç yorumu: Safra kesesi inflamasyonu lehine bulgular içerir. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Yorum: Safra kesesi inflamasyonu lehine bulgular içerir. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. // Safra kesesi inflamasyonu lehine bulgular içerir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-057 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Klinik anlam: Safra kesesi inflamasyonu lehine bulgular içerir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/057_057-akut-kolesistit-abdominal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/057_057-akut-kolesistit-abdominal-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-274 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Sağ üst kadranda belirgin hassasiyet vardır ve derin inspirasyon sırasında palpasyonla ağrı nedeniyle inspirasyon kesilmektedir. | Klinik anlam: Akut kolesistit | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/274_medical_exam_in_progress.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/274_medical_exam_in_progress.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Sağ üst kadranda belirgin hassasiyet vardır ve derin inspirasyon sırasında palpasyonla ağrı nedeniyle inspirasyon kesilmektedir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut kolesistit
B) Akut viral hepatit
C) Akut pankreatit
D) Peptik ülser perforasyonu
E) Akut apandisit

Doğru Cevap: Akut kolesistit

- A) Akut kolesistit: Akut kolesistit sağ üst kadranda ağrısı, ateş, lökositoz, taş ve safra kesesi duvar kalınlaşmasıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.” ve “Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Akut viral hepatit: Akut viral hepatitte yaygın halsizlik, belirgin transaminaz yüksekliği ve hepatoselüler tablo beklenir; lokal Murphy bulgusu ve taşlı kese paterni daha farklıdır. Bu olguda “Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.” ve “Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Akut pankreatit: Akut pankreatitte epigastrik ağrının sırtta yayılması ve pankreatik enzim yüksekliği beklenir; ultrasonografideki safra kesesi inflamasyonu bu olguda belirleyicidir. Bu olguda “Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.” ve “Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Peptik ülser perforasyonu: Peptik ülser perforasyonunda ani yaygın peritonit ve serbest hava beklenir; bu hastada lokal safra kesesi inflamasyon bulguları vardır. Bu olguda “Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.” ve “Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Akut apandisit: Akut apandisit genellikle sağ alt kadranda ağrısı ve lokal periton bulgularıyla seyreder; ağrı lokalizasyonu ve ultrason bulguları kolesistit lehinedir. Bu olguda “Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.” ve “Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sağ üst kadranda ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.” ve “Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.” birlikte okunduğunda Akut kolesistit seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide safra kesesi taşı, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda ağrısı, ateş, lökositoz, inspirasyonla ağrının artması ve ultrasonografide taşla birlikte safra kesesi duvar kalınlaşması akut kolesistiti düşündürür. Önceki kısa ataklar biliyer kolik öyküsünü desteklerken bu kez inflamasyon bulguları tabloyu akut kolesistite taşır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.”, “Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.” ve “Ultrasonografide safra kesesi taşı, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut kolesistit en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ağrı yağlı öğün sonrası sağ üst kadranda başlamıştır.

Kanıt 2: Muayenede inspirasyonla kesilen sağ üst kadranda ağrısı vardır.

Kanıt 3: Ultrasonografide safra kesesi taşı, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Safra taşı ağrısına ateş, lökositöz ve ultrasonografide duvar kalınlaşması eklenirse akut kolesistit düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 95: v174-new-095-acilik-sonrasi-hipoglisemik-atak

Başlık: Açlık sonrası hipoglisemik atak

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: MCAD eksikliğinde hipoketotik hipoglisemi mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında beslenememe sonrası bilinç bulanıklığı nedeniyle acile getiriliyor. Son 24 saattir ateş ve iştahsızlık nedeniyle çok az beslendiği, sabah uyandırılmadığı öğreniliyor. Daha önce uzun açlık sonrası halsizlik atakları olduğu belirtiliyor.

Demografi: 18 aylık erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 142/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.1°C | Şok indeksi: 1,61 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk letarjik ve soluk görünümündedir.
- Hepatomegali hafif derecede vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Ciddi hipoglisemi mevcuttur. | Sonuç yorumu: Ciddi hipoglisemi mevcuttur. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Ciddi hipoglisemi mevcuttur. | Satırlar: Kan glukozu / 34 mg/dL / 70-100 mg/dL / Ciddi hipoglisemi mevcuttur.

Tetkik 2: Serum ketonları

Etiket: Serum ketonları | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Beklenenden düşük saptandı. | Klinik anlam: Açlığa rağmen ketogenez yetersizdir. | Sonuç yorumu: Açlığa rağmen ketogenez yetersizdir. | Sonuç başlığı: Açık-karnitin profili | Sonuç özeti: Orta zincirli açıl-karnitin türlerinde artış saptandı. | Yorum: Yağ asidi beta-oksidasyon bozukluğunu destekler. | Satırlar: Serum ketonları / Beklenenden düşük saptandı. // Açlığa rağmen ketogenez yetersizdir.

Tetkik 3: Açıl-karnitin profili

Etiket: Açıl-karnitin profili | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Orta zincirli açıl-karnitin türlerinde artış saptandı. | Klinik anlam: Yağ asidi beta-oksidasyon bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Yağ asidi beta-oksidasyon bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Açıl-karnitin profili | Sonuç özeti: Orta zincirli açıl-karnitin türlerinde artış saptandı. // Yağ asidi beta-oksidasyon bozukluğunu destekler. | Satırlar: Açıl-karnitin profili / Orta zincirli açıl-karnitin türlerinde artış saptandı. // Yağ asidi beta-oksidasyon bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hipogliseminin temel biyokimyasal mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması
- B) Glukoz-6-fosfataz eksikliği nedeniyle glikojenoliz son ürününün kana verilememesi
- C) Fruktoz-1-fosfat birikimi nedeniyle fosfat tuzaklanması
- D) Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat artışı
- E) Fenilalanin yıkımının bozulması nedeniyle nörotoksik metabolit birikimi

Doğru Cevap: Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması

A) Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması: Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyon bozukluğu açlıkta keton üretimini azaltarak hipoketotik hipoglisemiye açıklar. Vakadaki "Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Glukoz-6-fosfataz eksikliği nedeniyle glikojenoliz son ürününün kana verilememesi: Glukoz-6-fosfataz eksikliği hepatomegali ve laktik asidozla seyrederek; bu olguda ayırt edici bulgu orta zincirli açıl-karnitin artışıdır. Bu olguda "Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Fruktoz-1-fosfat birikimi nedeniyle fosfat tuzaklanması: Fruktoz-1-fosfat birikimi hereditör fruktoz intoleransını düşündürür ve fruktoz alımı sonrası semptom beklenir. Bu olguda "Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi nedeniyle laktat artışı: Pirüvatın asetil-CoA'ya dönüşmemesi pirüvat dehidrogenaz eksikliğinde laktik asidozla ilişkilidir; hipoketotik açlık hipoglisemisini en iyi açıklamaz. Bu olguda "Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Fenilalanin yıkımının bozulması nedeniyle nörotoksik metabolit birikimi: Fenilalanin yıkım bozukluğu fenilketonüri ile ilişkilidir; açlıkla tetiklenen hipoketotik hipoglisemi paternine uymaz. Bu olguda "Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlık sonrası hipoglisemik atak olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür." birlikte okunduğunda Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması seçeneği öne çıkar; "Açıl-karnitin profilinde orta zincirli türlerde artış saptanmıştır." ise ayrıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uzun açlık veya enfeksiyon sonrası gelişen hipoketotik hipoglisemi ve orta zincirli açıl-karnitin artışı MCAD eksikliğini düşündürür. Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonu bozulduğunda açlıkta enerji ve asetil-CoA üretimi azalır; ketogenez yetersiz kalır ve glukoneogenez desteklenemez. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir.", "Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür." ve "Açıl-karnitin

profilinde orta zincirli türlerde artış saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Orta zincirli yağ asitlerinin beta-oksidasyonunun bozulması nedeniyle keton cisimciği üretiminin azalması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Atak enfeksiyon sırasında uzun süre beslenememe sonrası gelişmiştir.

Kanıt 2: Hipoglisemiye rağmen keton yanıtı düşüktür.

Kanıt 3: Açıl-karnitin profilinde orta zincirli türlerde artış saptanmıştır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: MCAD eksikliği açlık sonrası hipoketotik hipoglisemi yapar; tedavide uzun açlıktan kaçınmak kritiktir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 96: v174-new-096-agrisiz-servikal-lenfadenopati

Başlık: Ağrısız servikal lenfadenopati

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Hodgkin lenfomada Reed-Sternberg hücrelerini ve klinik paterni tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, boyunda ağrısız şişlik ve gece terlemeleri nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki aydır sol boyun bölgesinde büyüyen ağrısız lenf nodu olduğunu, son haftalarda gece terlemesi ve istemsiz kilo kaybı yaşadığını belirtiyor. Yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemiştir.

Demografi: 24 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 0,75

Fizik Muayene

- Sol servikal bölgede lastik kıvamında, ağrısız, hareketli lenf nodları palpe edilir.
- Hepatosplenomegali belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi

Etiket: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Karışık inflamatuvar zemin içinde büyük, iki çekirdekli, belirgin nükleollü hücreler izlendi. | Klinik anlam: Lenfoid neoplazi alt tipini düşündüren morfolojidir. | Sonuç yorumu: Lenfoid neoplazi alt tipini düşündüren morfolojidir. | Sonuç başlığı: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi | Sonuç özeti: Karışık inflamatuvar zemin içinde büyük, iki çekirdekli, belirgin nükleollü hücreler izlendi. | Yorum: Lenfoid neoplazi alt tipini düşündüren morfolojidir. | Satırlar: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi / Karışık inflamatuvar zemin içinde büyük, iki çekirdekli, belirgin nükleollü hücreler izlendi. // Lenfoid neoplazi alt tipini düşündüren morfolojidir.

Tetkik 2: İmmünohistokimya

Etiket: İmmünohistokimya | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Büyük atipik hücrelerde CD15 ve CD30 pozitifliği saptandı. | Klinik anlam: Klasik Hodgkin lenfoma lehine destek sağlar. | Sonuç yorumu: Klasik Hodgkin lenfoma lehine destek sağlar. | Sonuç başlığı: İmmünohistokimya | Sonuç özeti: Büyük atipik hücrelerde CD15 ve CD30 pozitifliği saptandı. | Yorum: Klasik Hodgkin lenfoma lehine destek sağlar. | Satırlar: İmmünohistokimya / Büyük atipik hücrelerde CD15 ve CD30 pozitifliği saptandı. // Klasik Hodgkin lenfoma lehine destek sağlar.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-058 | Başlık: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Karışık inflamatuvar zemin içinde büyük, iki çekirdekli, belirgin nükleollü hücreler izlendi. | Klinik anlam: Lenfoid neoplazi alt tipini düşündüren morfolojidir. | URL:

https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/058_058-reed-sternberg-hucresi-lenf-nodu-histopatoloji.webp | Thumbnail:

https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/058_058-reed-sternberg-hucresi-lenf-nodu-histopatoloji.webp | Alt text: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi - Karışık inflamatuvar zemin içinde büyük, iki çekirdekli, belirgin nükleollü hücreler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada tanıyı destekleyen karakteristik hücresel bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Reed-Sternberg hücresi
B) Auer çubuğu içeren miyeloblast
C) Sézary hücresi
D) Touton dev hücresi
E) Langhans tipi dev hücre

Doğru Cevap: Reed-Sternberg hücresi

- A) Reed-Sternberg hücresi: Reed-Sternberg hücresi klasik Hodgkin lenfomada karışık inflamatuvar zemin içinde görülen karakteristik büyük atipik hücredir. Vakadaki “Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.” ve “Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Auer çubuğu içeren miyeloblast: Auer çubuğu içeren miyeloblast akut miyeloid lösemiyle ilişkilidir; lenf nodu zeminindeki CD15-CD30 pozitif büyük hücreyi açıklamaz. Bu olguda “Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.” ve “Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.” ipuçları tanısal karar açısından Reed-Sternberg hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Sézary hücresi: Sézary hücresi kutanöz T hücreli lenfoma ve eritrodermiyle ilişkilidir; bu Vakadaki servikal lenfadenopati paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.” ve “Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.” ipuçları tanısal karar açısından Reed-Sternberg hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Touton dev hücresi: Touton dev hücresi ksantomatöz lezyonlarda görülebilir; klasik Hodgkin lenfoma tanısal hücresi değildir. Bu olguda “Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.” ve “Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.” ipuçları tanısal karar açısından Reed-Sternberg hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Langhans tipi dev hücre: Langhans tipi dev hücre granüloamatöz inflamasyonlarda beklenir; CD15-CD30 pozitif iki çekirdekli hücre bulgusunu açıklamaz. Bu olguda “Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.” ve “Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.” ipuçları tanısal karar açısından Reed-Sternberg hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ağrısız servikal lenfadenopati olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.” ve “Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.” birlikte okunduğunda Reed-Sternberg hücresi seçeneği öne çıkar; “Biyopside iki çekirdekli belirgin nükleollü büyük hücreler ve CD15-CD30 pozitifliği saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Genç erişkinde ağrısız servikal lenfadenopati, B semptomları, karışık inflamatuvar zeminde iki çekirdekli belirgin nükleollü büyük hücreler ve CD15-CD30 pozitifliği klasik Hodgkin lenfomayı destekler. Bu tümör için karakteristik hücre Reed-Sternberg hücresidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.”, “Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.” ve “Biyopside iki çekirdekli belirgin nükleollü büyük hücreler ve CD15-CD30 pozitifliği saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Reed-Sternberg hücresi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.

Kanıt 2: Gece terlemesi ve kilo kaybı B semptomlarını düşündürür.

Kanıt 3: Biyopside iki çekirdekli belirgin nükleollü büyük hücreler ve CD15-CD30 pozitifliği saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Klasik Hodgkin lenfomada Reed-Sternberg hücreleri tipik olarak CD15 ve CD30 pozitifdir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 97: v174-new-097-egzersizde-bolgesel-kan-akimi-artisi

Başlık: Egzersizde bölgesel kan akımı artışı

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Egzersizde iskelet kası kan akımını artıran lokal metabolik mekanizmaları açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Öğrencide kısa süreli yoğun ön kol egzersizi sonrası lokal kan akımı değişiklikleri inceleniyor. Bilinen kardiyovasküler hastalığı veya ilaç kullanımı yoktur. Deney sırasında el dinamometresiyle tekrarlayan izometrik kasılmalar yapmıştır.

Demografi: 22 yaşında sağlıklı erkek öğrenci | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/72 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Egzersiz sonrası çalışan ön kolda cilt sıcaklığı ve yüzeysel damar belirginliği artmıştır.
- Karşı ön kolda benzer belirgin vazodilatasyon izlenmez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Doppler akım ölçümü

Etiket: Doppler akım ölçümü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Egzersiz yapan ön kolda kan akımı belirgin artmış saptandı. | Klinik anlam: Lokal aktif hiperemi yanıtını gösterir. | Sonuç yorumu: Lokal aktif hiperemi yanıtını gösterir. | Sonuç başlığı: Doppler akım ölçümü | Sonuç özeti: Egzersiz yapan ön kolda kan akımı belirgin artmış saptandı. | Yorum: Lokal aktif hiperemi yanıtını gösterir. | Satırlar: Doppler akım ölçümü / Egzersiz yapan ön kolda kan akımı belirgin artmış saptandı. // Lokal aktif hiperemi yanıtını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-059 | Başlık: Doppler akım ölçümü | Modalite: ultrasound | Bulgu: Egzersiz yapan ön kolda kan akımı belirgin artmış saptandı. | Klinik anlam: Lokal aktif hiperemi yanıtını gösterir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/059_059-aktif-hiperemi-doppler-akim-olcumu.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/059_059-aktif-hiperemi-doppler-akim-olcumu.webp | Alt text: Doppler akım ölçümü - Egzersiz yapan ön kolda kan akımı belirgin artmış saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Egzersiz yapan kasta kan akımının artmasını sağlayan temel lokal mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon
- B) Lokal oksijen basıncının artmasına bağlı arterioller vazokonstriksiyon
- C) Parasempatik vagal uyarının iskelet kası arteriyollerini doğrudan kasması
- D) Renin-anjiotensin sisteminin lokal olarak baskılanmasıyla venöz dönüşün tamamen durması
- E) Kapiller hidrostatik basıncın azalmasıyla doku sıvısının tamamen geri emilmesi

Doğru Cevap: Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon

A) Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon: Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışı çalışan kasta arterioller vazodilatasyon ve aktif hiperemiyi açıklar. Vakadaki “Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.” ve “Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.” ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereksinimi karşılar.

B) Lokal oksijen basıncının artmasına bağlı arterioller vazokonstriksiyon: Lokal oksijen basıncı çalışan kasta artmaz, tüketim nedeniyle düşme eğilimindedir; vazodilatasyon ihtiyacı bu metabolik değişikliklerle ilişkilidir. Bu olguda “Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.” ve “Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.” ifadeleri mekanizma bilgisi açısından Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Parasempatik vagal uyarının iskelet kası arteriyollerini doğrudan kasması: Parasempatik vagal uyarı iskelet kası arteriyollerinin temel doğrudan kontrol mekanizması değildir; yanıt lokal metabolitlerle açıklanır. Bu olguda “Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.” ve “Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.” ifadeleri mekanizma bilgisi açısından Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Renin-anjiotensin sisteminin lokal olarak baskılanmasıyla venöz dönüşün tamamen durması: Renin-anjiotensin sisteminin venöz dönüşü tamamen durdurması fizyolojik bir egzersiz yanıtı değildir ve lokal aktif hiperemiyi açıklamaz. Bu olguda “Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.” ve “Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.” ifadeleri mekanizma bilgisi açısından Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kapiller hidrostatik basıncın azalmasıyla doku sıvısının tamamen geri emilmesi: Kapiller hidrostatik basınç ve doku sıvısı dengesi kan akımı artışının ana düzenleyicisi değildir; temel olay arterioller direnç azalmasıdır. Bu olguda “Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.” ve “Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.” ifadeleri mekanizma bilgisi açısından Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Egzersizde bölgesel kan akımı artışı olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.” ve “Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.” birlikte okunduğunda Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon seçeneği öne çıkar; “Karşı ön kolda benzer belirgin vazodilatasyon olmaması lokal mekanizmayı destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çalışan iskelet kasında metabolik aktivite arttıkça adenoazin, karbondioksit, hidrojen iyonu, potasyum ve diğer vazodilatör metabolitler birikir. Bu lokal metabolik faktörler arteriollerin gevşeterek aktif hiperemi oluşturur ve kan akımı çalışan kasın oksijen-enerji gereksinimine göre artar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.”, “Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.” ve “Karşı ön kolda benzer belirgin vazodilatasyon olmaması lokal mekanizmayı destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Lokal adenoazin, karbondioksit, potasyum ve hidrojen iyonu artışına bağlı arterioller vazodilatasyon en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kan akımı yalnızca egzersiz yapan ön kolda belirgin artmıştır.

Kanıt 2: Egzersiz tekrarlayan kas kasılmalarıyla lokal metabolik gereksinimi yükseltmiştir.

Kanıt 3: Karşı ön kolda benzer belirgin vazodilatasyon olmaması lokal mekanizmayı destekler.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Aktif hiperemide kan akımı merkezi emirden çok çalışan dokuda biriken lokal vazodilatör metabolitlerle artar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 98: v174-new-098-dis-islemi-sonrasi-subakut-ates

Başlık: Diş işlemi sonrası subakut ateş

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Endokarditte HACEK grubu etken özelliklerini klinik bağlamda tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, üç haftadır süren ateş, gece terlemesi ve halsizlik nedeniyle yatırılıyor. Yaklaşık bir ay önce diş çekimi yaptırdığı öğreniliyor. Bilinen mitral kapak prolapsusu vardır. Son haftalarda kilo kaybı ve efor kapasitesinde azalma tarifliyor.

Demografi: 41 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/70 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.2°C | Şok indeksi: 0,81

Fizik Muayene

- Kardiyak oskültasyonda apikal bölgede sistolik üfürüm duyulur.
- Tırnak yataklarında ince çizgisel hemorajiler izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: İnfektif endokardit lehinedir. | Sonuç yorumu: İnfektif endokardit lehinedir. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Yorum: İnfektif endokardit lehinedir. | Satırlar: Ekokardiyografi / Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. // İnfektif endokardit lehinedir.

Tetkik 2: Kan kültürü

Etiket: Kan kültürü | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Uzamış inkübasyon sonrası zor üreyen gram-negatif kokobasil üredi. | Klinik anlam: Orofarengeal flora kaynaklı özel etken grubunu düşündürür. | Sonuç yorumu: Orofarengeal flora kaynaklı özel etken grubunu düşündürür. | Sonuç başlığı: Kan kültürü | Sonuç özeti: Uzamış inkübasyon sonrası zor üreyen gram-negatif kokobasil üredi. | Yorum: Orofarengeal flora kaynaklı özel etken grubunu düşündürür. | Satırlar: Kan kültürü / Uzamış inkübasyon sonrası zor üreyen gram-negatif kokobasil üredi. // Orofarengeal flora kaynaklı özel etken grubunu düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-060 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Klinik anlam: İnfektif endokardit lehinedir. | URL: https://iukbtlkzicqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/060_060-mitral-vejetasyon-ekokardiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzicqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/060_060-mitral-vejetasyon-ekokardiyografi.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Mitral kapak üzerinde hareketli vejetasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik bağlamda en olası etken grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) HACEK grubu mikroorganizmalar
- B) Candida türleri
- C) Mycobacterium tuberculosis kompleksi
- D) Clostridium türleri
- E) Dermatofitler

Doğru Cevap: HACEK grubu mikroorganizmalar

- A) HACEK grubu mikroorganizmalar: HACEK grubu mikroorganizmalar diş işlemi sonrası subakut endokardit ve zor üreyen gram-negatif kokobasil bulgusuyla en uyumlu gruptur. Vakadaki “Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.” ve “Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Candida türleri: Candida türleri özellikle damar içi kateter, intravenöz ilaç kullanımı veya immünsüpresyonla ilişkili endokarditte düşünülür; burada orofarengeal kaynak ve gram-negatif kokobasil bulgusu vardır. Bu olguda “Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.” ve “Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından HACEK grubu mikroorganizmalar seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Mycobacterium tuberculosis kompleksi: Mycobacterium tuberculosis kompleksi kronik granülatöz enfeksiyonlarla ilişkilidir; tipik olarak diş işlemi sonrası kapak vejetasyonu ve zor üreyen gram-negatif kokobasil olarak beklenmez. Bu olguda “Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.” ve “Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından HACEK grubu mikroorganizmalar seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Clostridium türleri: Clostridium türleri anaerob gram-pozitif sporlu basillerdir; bu Vakadaki orofarengeal subakut endokardit paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.” ve “Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından HACEK grubu mikroorganizmalar seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Dermatofitler: Dermatofitler yüzeyel keratinize dokuları tutan mantarlardır; infektif endokardit ve kan kültürü bulgusunu açıklamaz. Bu olguda “Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.” ve “Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından HACEK grubu mikroorganizmalar seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Diş işlemi sonrası subakut ateş olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.” ve “Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.” birlikte okunduğunda HACEK grubu mikroorganizmalar seçeneği öne çıkar; “Kan kültüründe uzamış inkübasyon sonrası zor üreyen gram-negatif kokobasil üremiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Diş işlemi sonrası subakut endokardit, kapak hastalığı öyküsü, vejetasyon ve uzamış inkübasyonda zor üreyen gram-negatif kokobasil HACEK grubu mikroorganizmaları düşündürür. Bu grup orofarengeal florada bulunur ve özellikle subakut infektif endokardit etkenleri arasında yer alır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.”, “Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.” ve “Kan kültüründe uzamış inkübasyon sonrası zor üreyen gram-negatif kokobasil üremiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle HACEK grubu mikroorganizmalar en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Hastada diş çekimi sonrası subakut ateş ve sistemik yakınmalar gelişmiştir.

Kanıt 2: Mitral kapak üzerinde vejetasyon gösterilmiştir.

Kanıt 3: Kan kültüründe uzamış inkübasyon sonrası zor üreyen gram-negatif kokobasil üremiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: HACEK grubu orofarengeal flora kaynaklı, zor üreyen gram-negatif etkenlerdir ve subakut endokardit yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 99: v174-new-099-kasik-altinda-agrili-sislik

Başlık: Kasık altında ağrılı şişlik

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomi yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Femoral herninin anatomik sınırlarını ve strangülasyon riskini ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ kasık altında ağrılı şişlik ve bulantı nedeniyle acile başvuruyor. Şişliğin daha önce ara ara küçüldüğünü ancak son 8 saattir kaybolmadığını ve giderek ağrılı hale geldiğini belirtiyor. Çok doğum yapmış olduğu öğreniliyor.

Demografi: 72 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.7°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ inguinal ligamentin altında, pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen kitle palpe edilir.
- Batında hafif distansiyon vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yüzeysel yumuşak doku ultrasonografisi

Etiket: Yüzeysel yumuşak doku ultrasonografisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. | Klinik anlam: Herninin anatomik lokalizasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Herninin anatomik lokalizasyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Yüzeysel yumuşak doku ultrasonografisi | Sonuç özeti: Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. | Yorum: Herninin anatomik lokalizasyonunu destekler. | Satırlar: Yüzeysel yumuşak doku ultrasonografisi / Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. // Herninin anatomik lokalizasyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-061 | Başlık: Yüzeysel yumuşak doku ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. | Klinik anlam: Herninin anatomik lokalizasyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/061_061-femoral-herni-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/061_061-femoral-herni-ultrasonografi.webp | Alt text: Yüzeysel yumuşak doku ultrasonografisi - Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu herni tipinde kesenin geçtiği femoral kanalın lateral komşuluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Femoral ven
B) Femoral arter
C) Laküner ligament
D) İnguinal ligament
E) Pektineal ligament

Doğru Cevap: Femoral ven

- A) Femoral ven: Femoral ven femoral kanalın lateral komşusudur ve femoral herni anatomisinin ayırt edilmesinde temel yapıdır. Vakadaki “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Femoral arter: Femoral arter femoral venin lateralinde yer alır; femoral kanalın doğrudan lateral komşusu değildir. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Femoral ven seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Laküner ligament: Laküner ligament femoral kanalın medial sınırını oluşturur; lateral komşuluk olarak doğru değildir. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Femoral ven seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) İnguinal ligament: Vakadaki Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir ve Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Femoral ven seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Pektineal ligament: Pektineal ligament femoral kanalın posterior sınırıyla ilişkilidir; lateral komşu femoral vendir. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Femoral ven seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kasık altında ağrılı şişlik olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.” birlikte okunduğunda Femoral ven seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İnguinal ligamentin altında ve pubik tüberkülün lateralinde yerleşen ağrılı, redükte edilemeyen kitle femoral herniyi düşündürür. Femoral kanal femoral kılıfın medial kompartmanıdır; kanalın lateralinde femoral ven bulunur. Dar femoral halka nedeniyle strangülasyon riski yüksektir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.”, “Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.” ve “Ultrasonografide femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Femoral ven en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.

Kanıt 2: Pubik tüberkülün lateralinde ağrılı ve redükte edilemeyen şişlik vardır.

Kanıt 3: Ultrasonografide femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi gösterilmiştir.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olgusuyla uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Femoral herni inguinal ligamentin altında çıkar ve femoral kanalın lateral komşusu femoral vendir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 100: v174-new-100-gebeligin-gec-doneminde-agrisiz-kanama

Başlık: Gebeliğin geç döneminde ağrısız kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Plasenta previa olgusunda vajinal muayene öncesi uygun yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan parlak kırmızı vajinal kanama nedeniyle acile başvuruyor. Kanamanın ağrısız başladığını, karın ağrısı veya düzenli kasılma hissetmediğini belirtiyor. Daha önce iki kez sezaryen doğum yaptığı öğreniliyor. Fetal hareketleri hissetmektedir.

Demografi: 35 yaşında gebe hasta | Setting: Doğum acil ünitesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/72 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,81

Fizik Muayene

- Hasta hemodinamik olarak stabildir.
- Batında hassasiyet yoktur, uterus gevşektir.
- Spekulumla aktif parlak kırmızı kanama izlenir.
- Fetal kalp atımı 145/dk olarak izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada dijital vajinal muayene yapılmadan önce uygulanması gereken en uygun ilk değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi
- B) Dijital vajinal muayene ile servikal açıklığın hemen ölçülmesi
- C) Oksitosin infüzyonu başlanarak doğumun hızlandırılması
- D) Amniyotomi yapılarak kanamanın azaltılması
- E) Ayaktan yakın izlem ve planlı kontrol önermek

Doğru Cevap: Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi

A) Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi: Ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi, plasenta previa olasılığında dijital muayene öncesi güvenli ve doğru ilk yaklaşımdır. Vakadaki "Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır." ve "Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Dijital vajinal muayene ile servikal açıklığın hemen ölçülmesi: Dijital vajinal muayene plasenta previa varsa ciddi kanamayı artırabileceği için plasenta yerleşimi görülmeden yapılmamalıdır. Bu olguda "Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır." ve "Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Oksitosin infüzyonu başlanarak doğumun hızlandırılması: Oksitosin infüzyonu doğumu başlatabilir ancak plasenta previa olasılığı değerlendirilmeden kanamalı gebede uygun ilk yaklaşım değildir. Bu olguda "Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır." ve "Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Amniyotomi yapılarak kanamanın azaltılması: Vakadaki Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır ve Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur. Bu olguda "Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır." ve "Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ayaktan yakın izlem ve planlı kontrol önermek: Vakadaki Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır ve Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur. Bu olguda "Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır." ve "Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebeliğin geç döneminde ağrısız kanama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır." ve "Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur." birlikte okunduğunda Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi seçeneği öne çıkar; "Daha önce iki sezaryen doğum öyküsü plasenta yerleşim anomalisi riskini artırır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gebeliğin üçüncü trimesterinde ağrısız parlak kırmızı kanama ve önceki sezaryen öyküsü plasenta previa olasılığını artırır. Plasenta yerleşimi ultrasonografi ile değerlendirilmeden dijital vajinal muayene yapılması ciddi kanamayı tetikleyebilir; bu nedenle ilk uygun değerlendirme ultrasonografidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır.", "Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur." ve "Daha önce iki sezaryen doğum öyküsü plasenta yerleşim anomalisi riskini artırır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Transvajinal veya transabdominal ultrasonografi ile plasenta yerleşiminin değerlendirilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanama gebeliğin 32. haftasında ağrısız ve parlak kırmızı şekilde başlamıştır.

Kanıt 2: Uterus gevşektir ve batin hassasiyeti yoktur.

Kanıt 3: Daha önce iki sezaryen doğum öyküsü plasenta yerleşim anomalisi riskini artırır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Üçüncü trimester ağrısız vajinal kanamada plasenta previa dışlanmadan dijital vajinal muayene yapılmaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 101: v175-new-101-lateral-boyun-kitlesi

Başlık: Lateral boyun kitlesi

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizma ve patofizyolojiyi klinik ipuçlarıyla yorumlama.

Learning Target: İkinci brankiyal yarık kistini lateral boyun kitlesi ve embriyolojik kökeniyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, boynun sol yan tarafında ağrısız şişlik nedeniyle başvuruyor. Şişliğin birkaç aydır var olduğunu, üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında büyüüp hassaslaşabildiğini belirtiyor. Yutma güçlüğü, kilo kaybı veya gece terlemesi tariflemiyor.

Demografi: 17 yaşında kadın hasta | Setting: Kulak burun boğaz polikliniğinde

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sol sternokleidomastoid kasın ön kenarı boyunca, yumuşak kıvamlı, düzgün sınırlı ve mobil kistik kitle palpe edilir.
- Kitle dil protrüzyonu ile belirgin hareket etmez.
- Tiroid muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Boyun ultrasonografisi

Etiket: Boyun ultrasonografisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sternokleidomastoid kas ön kenarı komşuluğunda ince duvarlı kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Lateral servikal embriyolojik kalıntı lehinedir. | Sonuç yorumu: Lateral servikal embriyolojik kalıntı lehinedir. | Sonuç başlığı: Boyun ultrasonografisi | Sonuç özeti: Sternokleidomastoid kas ön kenarı komşuluğunda ince duvarlı kistik lezyon izlendi. | Yorum: Lateral servikal embriyolojik kalıntı lehinedir. | Satırlar: Boyun ultrasonografisi / Sternokleidomastoid kas ön kenarı komşuluğunda ince duvarlı kistik lezyon izlendi. / / Lateral servikal embriyolojik kalıntı lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-062 | Başlık: Boyun ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sternokleidomastoid kas ön kenarı komşuluğunda ince duvarlı kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Lateral servikal embriyolojik kalıntı lehinedir. | URL: https://iukbtikzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/062_062-brankial-yarik-kisti-boyun-ultrasonografisi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/062_062-brankial-yarik-kisti-boyun-ultrasonografisi.webp | Alt text: Boyun ultrasonografisi - Sternokleidomastoid kas ön kenarı komşuluğunda ince duvarlı kistik lezyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki kitlenin embriyolojik kökeni en olası olarak aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tiroglossal kanal kalıntısı
B) İkinci faringeal yarığın persiste kalıntısı
C) Ürakuş kalıntısı
D) Omfalomezenterik kanal kalıntısı
E) Duktus arteriozus kalıntısı

Doğru Cevap: İkinci faringeal yarığın persiste kalıntısı

A) Tiroglossal kanal kalıntısı: Tiroglossal kanal kalıntısı orta hatta hyoid komşuluğunda ve dil protrüzyonuyla hareket eden kitle yapar; bu olgu lateral yerleşimlidir. Bu olguda “Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.” ve “Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından ikinci faringeal yarığın persiste kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.

B) İkinci faringeal yarığın persiste kalıntısı: İkinci faringeal yarığın persiste kalıntısı sternokleidomastoid kas ön kenarında lateral kistik boyun kitlesi oluşturur. Vakadaki “Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.” ve “Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Ürakuş kalıntısı: Ürakuş kalıntısı umbilikus ve mesane arasındaki gelişimsel kalıntılarla ilişkilidir; lateral boyun kitlesini açıklamaz. Bu olguda “Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.” ve “Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından ikinci faringeal yarığın persiste kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Omfalomezenterik kanal kalıntısı: Omfalomezenterik kanal kalıntısı Meckel divertikülü gibi ileal anomalilere yol açar; servikal kistik kitle oluşturmaz. Bu olguda “Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.” ve “Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından ikinci faringeal yarığın persiste kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Duktus arteriozus kalıntısı: Duktus arteriozus kalıntısı kardiyovasküler bir fetal damar kalıntısıdır; boyunda kistik lezyonun embriyolojik kökeni değildir. Bu olguda “Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.” ve “Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından ikinci faringeal yarığın persiste kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Lateral boyun kitlesi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.” ve “Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.” birlikte okunduğunda ikinci faringeal yarığın persiste kalıntısı seçeneği öne çıkar; “Dil protrüzyonu ile belirgin hareket etmemesi orta hat tiroglossal kanal kistini geri plana iter.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sternokleidomastoid kasın ön kenarı boyunca yerleşen lateral kistik boyun kitlesi brankiyal yarık kistini düşündürür. En sık ikinci faringeal yarık kalıntısından gelişir ve orta hat tiroglossal kanal kistinden farklı olarak dil protrüzyonu ile belirgin hareket etmez. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.”, “Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.” ve “Dil protrüzyonu ile belirgin hareket etmemesi orta hat tiroglossal kanal kistini geri plana iter.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle ikinci faringeal yarığın persiste kalıntısı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kitle boynun lateralinde sternokleidomastoid kas ön kenarı boyunca yerleşmiştir.

Kanıt 2: Lezyon kistik, düzgün sınırlı ve mobil olarak tanımlanmıştır.

Kanıt 3: Dil protrüzyonu ile belirgin hareket etmemesi orta hat tiroglossal kanal kistini geri plana iter.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Lateral boyun kisti çoğunlukla ikinci brankiyal yarık kalıntısıdır; tiroglossal kanal kisti ise orta hatta ve dil hareketiyle hareketlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 102: v175-new-102-prenatal-taramada-yuksek-alfa-fetoprotein

Başlık: Prenatal taramada yüksek alfa-fetoprotein

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizma ve patofizyolojiyi klinik ipuçlarıyla yorumlama.

Learning Target: Nöral tüp kapanma kusurunu folat eksikliği ve prenatal tarama bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, rutin prenatal taramada maternal serum alfa-fetoprotein yüksekliği nedeniyle yönlendiriliyor. Gebeliğin planlanmadan olduğu ve ilk trimesterde düzenli folik asit kullanmadığı öğreniliyor. Ailede bilinen kromozomal hastalık öyküsü yoktur. Anne belirgin enfeksiyon veya ilaç maruziyeti tariflemiyor.

Demografi: 26 yaşında gebe hasta | Setting: Gebeliğinin 18. haftasında perinatoloji polikliniğinde

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Obstetrik muayenede akut kanama veya uterin hassasiyet yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Maternal serum alfa-fetoprotein

Etiket: Maternal serum alfa-fetoprotein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Gebelik haftasına göre yüksek saptandı. | Klinik anlam: Açık fetal defekt olasılığını artırır. | Sonuç yorumu: Açık fetal defekt olasılığını artırır. | Sonuç başlığı: Maternal serum alfa-fetoprotein | Sonuç özeti: Gebelik haftasına göre yüksek saptandı. | Yorum: Açık fetal defekt olasılığını artırır. | Satırlar: Maternal serum alfa-fetoprotein / Gebelik haftasına göre yüksek saptandı. // Açık fetal defekt olasılığını artırır.

Tetkik 2: Ayrıntılı fetal ultrasonografi

Etiket: Ayrıntılı fetal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Lumbosakral bölgede açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlendi. | Klinik anlam: Açık nöral tüp defektini destekler. | Sonuç yorumu: Açık nöral tüp defektini destekler. | Sonuç başlığı: Ayrıntılı fetal ultrasonografi | Sonuç özeti: Lumbosakral bölgede açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlendi. | Satırlar: Ayrıntılı fetal ultrasonografi / Lumbosakral bölgede açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlendi. // Açık nöral tüp defektini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-063 | Başlık: Ayrıntılı fetal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Lumbosakral bölgede açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlendi. | Klinik anlam: Açık nöral tüp defektini destekler. | URL: https://iukbtlkzxtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/063_063-spina-bifida-aperta-fetal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/063_063-spina-bifida-aperta-fetal-ultrasonografi.webp | Alt text: Ayrıntılı fetal ultrasonografi - Lumbosakral bölgede açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu fetal anomalinin temel gelişimsel mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kaudal nöroporun kapanma kusuru
B) Rostral nöroporun kapanma kusuru
C) Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayırlanamaması
D) Üçüncü faringeal poşun gelişmemesi
E) Midgutun superior mezenterik arter etrafında aşırı rotasyonu

Doğru Cevap: Kaudal nöroporun kapanma kusuru

- A) Kaudal nöroporun kapanma kusuru: Kaudal nöroporun kapanma kusuru lumbosakral açık nöral tüp defekti ve yüksek alfa-fetoprotein bulgusunu açıklar. Vakadaki “İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.” ve “Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Rostral nöroporun kapanma kusuru: Rostral nöropor kapanma kusuru anensefali gibi kranial nöral tüp defektleriyle ilişkilidir; bu olguda lumbosakral defekt vardır. Bu olguda “İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.” ve “Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöroporun kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayırlanamaması: Ön bağırsağın trakea ve özofagusa ayırlanamaması trakeoözofageal fistül mekanizmasıdır; vertebral ark defektini açıklayamaz. Bu olguda “İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.” ve “Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöroporun kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Üçüncü faringeal poşun gelişmemesi: Üçüncü faringeal poş gelişim kusuru timus ve paratiroid anomalilerine yol açar; nöral tüp kapanma bozukluğu değildir. Bu olguda “İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.” ve “Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöroporun kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Midgutun superior mezenterik arter etrafında aşırı rotasyonu: Midgut rotasyon bozuklukları intestinal obstrüksiyon veya volvulusla ilişkilidir; spinal açık defektlerle ilişkili değildir. Bu olguda “İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.” ve “Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöroporun kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Prenatal taramada yüksek alfa-fetoprotein olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.” ve “Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.” birlikte okunduğunda Kaudal nöroporun kapanma kusuru seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide lumbosakral açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Maternal serum alfa-fetoprotein yüksekliği ve lumbosakral açık vertebral ark defekti spina bifida aperta ile uyumludur. Bu anomalinin temelinde kaudal nöroporun embriyonik dönemde kapanamaması yer alır; folat eksikliği nöral tüp kapanma kusurları için önemli bir risk faktörüdür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.”, “Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.” ve “Ultrasonografide lumbosakral açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kaudal nöroporun kapanma kusuru en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: İlk trimesterde düzenli folik asit kullanılmamıştır.

Kanıt 2: Maternal serum alfa-fetoprotein gebelik haftasına göre yüksek bulunmuştur.

Kanıt 3: Ultrasonografide lumbosakral açık vertebral ark defekti ve meningeal keselenme izlenmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Kaudal nöropor kapanma kusuru spina bifida; rostral nöropor kapanma kusuru anensefali ile ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 103: v175-new-103-hipotansiyon-ve-hiperpigmentasyon

Başlık: Hipotansiyon ve hiperpigmentasyon

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizma ve patofizyolojiyi klinik ipuçlarıyla yorumlama.

Learning Target: Primer adrenal yetmezlikte elektrolit ve hormon değişikliklerini fizyolojik mekanizmayla açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kronik halsizlik, kilo kaybı ve ayağa kalkınca baş dönmesi nedeniyle başvuruyor. Son aylarda tuzlu yiyeceklere belirgin istek duyduğunu, iştahsızlık ve bulantı yaşadığını belirtiyor. Cildinin özellikle güneş görmeyen bölgelerde koyulaştığını fark etmiştir.

Demografi: 36 yaşında kadın hasta | Setting: Endokrinoloji polikliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: Yatar 94/58 mmHg; ayakta 78/48 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta zayıf ve halsiz görünümündedir.
- Oral mukozada ve avuç çizgilerinde hiperpigmentasyon vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. (128 mmol/L). | Klinik anlam: Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumludur. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumludur. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. (128 mmol/L). | Yorum: Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumludur. | Satırlar: Serum sodyum / 128 mmol/L / 135-145 mmol/L / Mineralokortikoid eksikliğiyle uyumludur.

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. (5.8 mmol/L). | Klinik anlam: Aldosteron eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: Aldosteron eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. (5.8 mmol/L). | Yorum: Aldosteron eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum potasyum / 5.8 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Aldosteron eksikliğini destekler.

Tetkik 3: Sabah kortizolü

Etiket: Sabah kortizolü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. (2.1 µg/dL). | Klinik anlam: Adrenal korteks yetmezliğini destekler. | Sonuç yorumu: Adrenal korteks yetmezliğini destekler. | Sonuç başlığı: Sabah kortizolü | Sonuç özeti: Düşük saptandı. (2.1 µg/dL). | Yorum: Adrenal korteks yetmezliğini destekler. | Satırlar: Sabah kortizolü / 2.1 µg/dL / 5-25 µg/dL / Adrenal korteks yetmezliğini destekler.

Tetkik 4: ACTH

Etiket: ACTH | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Primer adrenal yetmezlik lehinedir. | Sonuç yorumu: Primer adrenal yetmezlik lehinedir. | Sonuç başlığı: ACTH | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Primer adrenal yetmezlik lehinedir. | Satırlar: ACTH / Yüksek saptandı. // Primer adrenal yetmezlik lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-275 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Oral mukozada ve avuç çizgilerinde hiperpigmentasyon vardır. | Klinik anlam: ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması | URL: https://iukbtlkzicxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/275_oral_and_palmar_pigmentation_analysis.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzicxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/275_oral_and_palmar_pigmentation_analysis.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Oral mukozada ve avuç çizgilerinde hiperpigmentasyon vardır. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hiperpigmentasyonun temel fizyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması
- B) Aldosteron fazlalığına bağlı melanin sentezinin doğrudan baskılanması
- C) Tiroid hormon fazlalığına bağlı epidermal keratin yıkımının artması
- D) İnsülin eksikliğine bağlı melanositlerin tamamen inaktive olması
- E) Paratiroid hormon artışına bağlı dermal kalsifikasyon gelişmesi

Doğru Cevap: ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması

- A) ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması: ACTH öncülü proopiomelanokortin artışı melanokortin etkisini artırarak primer adrenal yetmezlikte hiperpigmentasyonu açıklar. Vakadaki “Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Aldosteron fazlalığına bağlı melanin sentezinin doğrudan baskılanması: Aldosteron fazlalığı değil eksikliği vardır; melanin sentezini doğrudan baskılayan mekanizma bu tabloyu açıklamaz. Bu olguda “Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Tiroid hormon fazlalığına bağlı epidermal keratin yıkımının artması: Tiroid hormon fazlalığı bu hastadaki hiperkalemi, düşük kortizol ve yüksek ACTH paternini açıklamaz. Bu olguda “Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) İnsülin eksikliğine bağlı melanositlerin tamamen inaktive olması: İnsülin eksikliği hiperpigmentasyonun temel nedeni değildir; bu hastada adrenal eksen bozukluğu verilmiştir. Bu olguda “Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Paratiroid hormon artışına bağlı dermal kalsifikasyon gelişmesi: Paratiroid hormon artışı dermal kalsifikasyonla ilişkili olabilir ancak mukozal hiperpigmentasyon ve ACTH yüksekliğini açıklamaz. Bu olguda “Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hipotansiyon ve hiperpigmentasyon olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.” birlikte okunduğunda ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması seçeneği öne çıkar; “Oral mukoza ve avuç çizgilerinde hiperpigmentasyon gözlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Düşük kortizol, yüksek ACTH, hiponatremi, hiperkalemi, ortostatik hipotansiyon ve tuz isteği primer adrenal yetmezliği düşündürür. Kortizol eksikliği negatif geri bildirimi azaltır ve ACTH ile aynı öncül olan proopiomelanokortin türevleri artar; melanokortin etkisi hiperpigmentasyona yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.”, “Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.” ve “Oral mukoza ve avuç çizgilerinde hiperpigmentasyon gözlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle ACTH öncülü proopiomelanokortin artışına bağlı melanokortin etkisinin artması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kortizol düşük, ACTH yüksek saptanmıştır.

Kanıt 2: Hiponatremi, hiperkalemi ve ortostatik hipotansiyon adrenal korteks yetmezliğini destekler.

Kanıt 3: Oral mukoza ve avuç çizgilerinde hiperpigmentasyon gözlenmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Primer adrenal yetmezlikte ACTH yüksek olduğu için hiperpigmentasyon olur; sekonder yetmezlikte bu bulgu beklenmez.

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 104: v175-new-104-paroksismal-oksuruk-nobetleri

Başlık: Paroksismal öksürük nöbetleri

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Etken mikroorganizmayı klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Boğmaca etkenini klinik özellik ve toksin mekanizmasıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, tekrarlayan öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası morarma nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi bebeğin son bir haftadır giderek artan öksürük nöbetleri geçirdiğini, nöbetlerin bazen kusmayla sonlandığını belirtiyor. Aşılarının yaşına göre eksik olduğu öğreniliyor. Evde uzun süren öksürüğü olan erişkin temas öyküsü vardır.

Demografi: 3 aylık kız bebek | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/54 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 42/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 37.2°C | Şok indeksi: 1,53 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek öksürük nöbeti dışında uyanık ve hafif huzursuzdur.
- Nöbet sırasında ardışık öksürükler ve kısa süreli siyanoz izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lenfositoz saptandı. (24000 /mm³). | Klinik anlam: Boğmaca toksinine bağlı lenfosit yanıtını destekler. | Sonuç yorumu: Boğmaca toksinine bağlı lenfosit yanıtını destekler. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lenfositoz saptandı. (24000 /mm³). | Yorum: Boğmaca toksinine bağlı lenfosit yanıtını destekler. | Satırlar: Tam kan sayımı / 24000 /mm³ / 5000-15000 /mm³ / Boğmaca toksinine bağlı lenfosit yanıtını destekler.

Tetkik 2: Nazofarengeal PCR

Etiket: Nazofarengeal PCR | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Bordetella pertussis için pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni doğrular. | Sonuç yorumu: Etkeni doğrular. | Sonuç başlığı: Nazofarengeal PCR | Sonuç özeti: Bordetella pertussis için pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni doğrular. | Satırlar: Nazofarengeal PCR / Bordetella pertussis için pozitif saptandı. / Etkeni doğrular.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-276 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Nöbet sırasında ardışık öksürükler ve kısa süreli siyanoz izlenir. | Klinik anlam: Bordetella pertussis | URL: https://iukbtlkzicqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/276_medical_exam_room_close_up_of_leg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzicqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/276_medical_exam_room_close_up_of_leg.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Nöbet sırasında ardışık öksürükler ve kısa süreli siyanoz izlenir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bordetella pertussis
B) Haemophilus influenzae tip b
C) Respiratory syncytial virus
D) Corynebacterium diphtheriae
E) Mycoplasma pneumoniae

Doğru Cevap: Bordetella pertussis

A) Bordetella pertussis: Bordetella pertussis eksik aşıli bebekte paroksismal öksürük, posttussif kusma, lenfositoz ve pozitif PCR ile en uyumlu etkindir. Vakadaki “Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.” ve “Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Haemophilus influenzae tip b: Haemophilus influenzae tip b epiglottit ve invaziv enfeksiyon yapabilir; paroksismal öksürük ve belirgin lenfositoz tablosunu en iyi açıklamaz. Bu olguda “Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.” ve “Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Respiratory syncytial virus: Respiratory syncytial virus bronşiolit yapar; yaygın hışıltı ve alt solunum yolu bulguları beklenir, bu olguda PCR boğmaca etkenini göstermektedir. Bu olguda “Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.” ve “Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Corynebacterium diphtheriae: Corynebacterium diphtheriae farenkste psödomembran ve toksik miyokardit gibi bulgularla seyreder; paroksismal öksürük nöbetleri tipik değildir. Bu olguda “Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.” ve “Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Mycoplasma pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae okul çağı çocuk ve genç erişkinde atipik pnömoni yapar; bu süt çocuğundaki boğmaca paternini açıklamaz. Bu olguda “Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.” ve “Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Paroksismal öksürük nöbetleri olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.” ve “Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.” birlikte okunduğunda Bordetella pertussis seçeneği öne çıkar; “Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis için pozitif bulunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Eksik aşıli süt çocuğunda paroksismal öksürük, öksürük sonrası kusma, siyanoz ve belirgin lenfositoz boğmacayı düşündürür. Bordetella pertussis solunum epiteline toksin aracılı etki yapar; pertussis toksini G inhibitör proteini ADP-ribozilleyerek adenilat siklaz aktivitesini artırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.”, “Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis için pozitif bulunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Bordetella pertussis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebeğin aşıları yaşına göre eksiktir.

Kanıt 2: Tekrarlayan paroksismal öksürük nöbetleri ve öksürük sonrası kusma vardır.

Kanıt 3: Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis için pozitif bulunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Boğmacada paroksismal öksürük, posttussif kusma ve lenfositoz klasik ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 105: v175-new-105-bogaz-enfeksiyonu-sonrasi-koyu-idrar

Başlık: Boğaz enfeksiyonu sonrası koyu idrar

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulgu ve klinik tabloyu ilişkilendirme.

Learning Target: Poststreptokoksik glomerülonefritte nefritik sendrom ve immün kompleks paternini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, göz çevresinde şişlik ve çay renginde idrar nedeniyle getiriliyor. Ailesi iki hafta önce ateşli boğaz enfeksiyonu geçirdiğini, son birkaç gündür idrar renginin koyulaştığını ve sabahları göz kapaklarının şiştiğini belirtiyor. Daha önce böbrek hastalığı öyküsü yoktur.

Demografi: 9 yaşında erkek çocuk | Setting: Pediatrik nefroloji polikliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 138/88 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 0,74

Fizik Muayene

- Periorbital ödem mevcuttur.
- Akciğer oskültasyonunda belirgin ral yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar analizi

Etiket: İdrar analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hematüri ve eritrosit silindirleri saptandı. | Klinik anlam: Nefritik sendromu destekler. | Sonuç yorumu: Nefritik sendromu destekler. | Sonuç başlığı: İdrar analizi | Sonuç özeti: Hematüri ve eritrosit silindirleri saptandı. | Yorum: Nefritik sendromu destekler. | Satırlar: İdrar analizi / Hematüri ve eritrosit silindirleri saptandı. // Nefritik sendromu destekler.

Tetkik 2: Serum C3

Etiket: Serum C3 | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kompleman tüketimini düşündürür. | Sonuç yorumu: Kompleman tüketimini düşündürür. | Sonuç başlığı: Serum C3 | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kompleman tüketimini düşündürür. | Satırlar: Serum C3 / Düşük saptandı. // Kompleman tüketimini düşündürür.

Tetkik 3: Antistreptolizin O titresi

Etiket: Antistreptolizin O titresi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Yakın streptokok enfeksiyonu lehinedir. | Sonuç yorumu: Yakın streptokok enfeksiyonu lehinedir. | Sonuç başlığı: Antistreptolizin O titresi | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Yakın streptokok enfeksiyonu lehinedir. | Satırlar: Antistreptolizin O titresi / Yüksek saptandı. // Yakın streptokok enfeksiyonu lehinedir.

Tetkik 4: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi

Etiket: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri izlendi. | Klinik anlam: Hastalığa özgü patern açısından destekleyicidir. | Sonuç yorumu: Hastalığa özgü patern açısından destekleyicidir. | Sonuç başlığı: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Sonuç özeti: Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri izlendi. | Yorum: Hastalığa özgü patern açısından destekleyicidir. | Satırlar: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi / Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri izlendi. // Hastalığa özgü patern açısından destekleyicidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-064 | Başlık: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri izlendi. | Klinik anlam: Hastalığa özgü patern açısından destekleyicidir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/064_064-subepitelyal-hump-em.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/064_064-subepitelyal-hump-em.webp | Alt text: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi - Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-277 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Periorbital ödem mevcuttur. | Klinik anlam: Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/277_pediatric_eye_swelling_in_clinic_setting.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/277_pediatric_eye_swelling_in_clinic_setting.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Periorbital ödem mevcuttur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta beklenen karakteristik patolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lineer IgG birikimi
- B) Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri
- C) Nodüler glomerüloskleroz
- D) Mezangial IgA baskın birikimi
- E) Villus atrofi ve kript hiperplazisi

Doğru Cevap: Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri

- A) Lineer IgG birikimi: Lineer IgG birikimi anti-glomerüler bazal membran hastalığıyla ilişkilidir; bu olguda poststreptokoksik immün kompleks paterni vardır. Bu olguda “Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.” ve “İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.” ipuçları klinik karar açısından Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri: Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri poststreptokoksik glomerülonefrit için karakteristik patolojik bulgudur. Vakadaki “Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.” ve “İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- C) Nodüler glomerüloskleroz: Nodüler glomerüloskleroz diyabetik nefropatiyi düşündürür; boğaz enfeksiyonu sonrası akut nefritik tabloyu açıklamaz. Bu olguda “Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.” ve “İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.” ipuçları klinik karar açısından Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Mezangial IgA baskın birikimi: Mezangial IgA baskın birikimi IgA nefropatisinde beklenir ve genellikle enfeksiyonla eş zamanlı hematüri yapar; burada gecikmeli poststreptokoksik tablo vardır. Bu olguda “Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.” ve “İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.” ipuçları klinik karar açısından Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Villus atrofi ve kript hiperplazisi: Villus atrofi ve kript hiperplazisi çölyak hastalığının intestinal biyopsi bulgusudur; glomerüler nefritle ilişkili değildir. Bu olguda “Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.” ve “İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.” ipuçları klinik karar açısından Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Boğaz enfeksiyonu sonrası koyu idrar olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.” ve “İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.” birlikte okunduğunda Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri seçeneği öne çıkar; “Serum C3 düşüklüğü kompleman tüketimini göstermektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Streptokok farengiti sonrası gelişen hematüri, periorbital ödem, hipertansiyon, düşük C3 ve yüksek antistreptolizin O titresi poststreptokoksik glomerülonefrit düşündürür. Bu immün kompleks aracı nefritik tabloda elektron mikroskopisinde subepitelyal hump benzeri birikimler tipiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.”, “İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.” ve “Serum C3 düşüklüğü kompleman tüketimini göstermektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Subepitelyal hump benzeri immün kompleks birikimleri en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Koyu idrar ve eritrosit silindirleri nefritik sendromu destekler.

Kanıt 2: İki hafta önce boğaz enfeksiyonu geçirilmiş ve antistreptolizin O titresi yüksek bulunmuştur.

Kanıt 3: Serum C3 düşüklüğü kompleman tüketimini göstermektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Poststreptokoksik glomerülonefritte subepitelyal hump birikimleri ve düşük C3 klasik bulgulardır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 106: v175-new-106-sutle-beslenme-sonrasi-yenidogan-sariligi

Başlık: Sütle beslenme sonrası yenidoğan sarılığı

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizma ve patofizyolojiyi klinik ipuçlarıyla yorumlama.

Learning Target: Klasik galaktozemide enzim defekti ve klinik tabloyu ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme sonrası kusma, uzayan sarılık ve kilo alamama nedeniyle getiriliyor. Doğumdan sonra anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslendiği, birkaç gün içinde kusma, emmede azalma ve sarılığın belirginleştiği öğreniliyor. Ailede akraba evliliği vardır.

Demografi: 12 günlük erkek bebek | Setting: Çocuk metabolizma kliniğinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 150/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 37.1°C | Şok indeksi: 2,14 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve ikterik görünümündedir.
- Karaciğer kot altında 4 cm palpe edilir.
- Göz muayenesinde lens opasitesi şüphesi belirtilmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Direkt bilirubin

Etiket: Direkt bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. (4.2 mg/dL). | Klinik anlam: Kolestatik hepatik etkilenimi destekler. | Sonuç yorumu: Kolestatik hepatik etkilenimi destekler. | Sonuç başlığı: Direkt bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. (4.2 mg/dL). | Yorum: Kolestatik hepatik etkilenimi destekler. | Satırlar: Direkt bilirubin / 4.2 mg/dL | <0.3 mg/dL | Kolestatik hepatik etkilenimi destekler.

Tetkik 2: İdrarda indirgen madde

Etiket: İdrarda indirgen madde | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Galaktoz metabolizması bozukluğunu düşündürür. | Sonuç yorumu: Galaktoz metabolizması bozukluğunu düşündürür. | Sonuç başlığı: İdrarda indirgen madde | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Galaktoz metabolizması bozukluğunu düşündürür. | Satırlar: İdrarda indirgen madde / Pozitif saptandı. // Galaktoz metabolizması bozukluğunu düşündürür.

Tetkik 3: Enzim analizi

Etiket: Enzim analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Galactose-1-phosphate uridytransferase aktivitesi düşük saptandı. | Klinik anlam: Klasik enzim defektini destekler. | Sonuç yorumu: Klasik enzim defektini destekler. | Sonuç başlığı: Enzim analizi | Sonuç özeti: Galactose-1-phosphate uridytransferase aktivitesi düşük saptandı. | Yorum: Klasik enzim defektini destekler. | Satırlar: Enzim analizi / Galactose-1-phosphate uridytransferase aktivitesi düşük saptandı. // Klasik enzim defektini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-278 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Bebek letarjik ve ikterik görünümündedir. | Klinik anlam: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği | URL: https://iukbtlkzicxtdsds.public.blob.vercel-storage.com/278_infant_in_pediatric_emergency_room.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzicxtdsds.public.blob.vercel-storage.com/278_infant_in_pediatric_emergency_room.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Bebek letarjik ve ikterik görünümündedir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki temel biyokimyasal defekt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği
B) Fruktoz-1-fosfat aldolaz eksikliği
C) Glukoz-6-fosfataz eksikliği
D) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
E) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği

Doğru Cevap: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği

- A) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği sütle beslenme sonrası hepatik etkilenim, indirgen madde pozitifliği ve katarakt şüphesini açıklar. Vakadaki “Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.” ve “Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Fruktoz-1-fosfat aldolaz eksikliği: Fruktoz-1-fosfat aldolaz eksikliği fruktoz alımı sonrası semptom verir; yenidoğanda sütle başlayan tabloyu açıklamaz. Bu olguda “Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.” ve “Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.” ipuçları klinik karar açısından Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği açlık hipoglisemisi ve laktik asidozla seyredir; laktoz sonrası kolestatik sarılık paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.” ve “Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.” ipuçları klinik karar açısından Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ornitin transkarbamilaz eksikliği: Ornitin transkarbamilaz eksikliği ağır hiperammonemi ve orotik asit yüksekliğiyle ilişkilidir; bu olguda galaktoz metabolizması bulguları baskındır. Bu olguda “Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.” ve “Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.” ipuçları klinik karar açısından Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüriye neden olur; sütle beslenme sonrası akut hepatik sarılık ve katarakt şüphesini açıklamaz. Bu olguda “Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.” ve “Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.” ipuçları klinik karar açısından Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sütle beslenme sonrası yenidoğan sarılığı olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.” ve “Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.” birlikte okunduğunda Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği seçeneği öne çıkar; “Enzim analizinde galactose-1-phosphate uridytransferase aktivitesi düşük bulunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Laktoz içeren beslenme sonrası kusma, letarji, kolestatik sarılık, hepatomegali, katarakt şüphesi ve idrarda indirgen madde pozitifliği klasik galaktozemiye düşündürür. Temel defekt galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliğidir; tedavide galaktoz ve laktoz diyetten çıkarılmalıdır. Bu olguda

kararın temel ayrımı, “Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.”, “Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.” ve “Enzim analizinde galactose-1-phosphate uridyltransferase aktivitesi düşük bulunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Galactose-1-phosphate uridyltransferase eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Şikâyetler anne sütü ve laktoz içeren mama ile beslenme sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Sarılık, hepatomegali ve direkt bilirubin yüksekliği hepatik etkilenimi destekler.

Kanıt 3: Enzim analizinde galactose-1-phosphate uridyltransferase aktivitesi düşük bulunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Klasik galaktozemide erken dönemde laktoz kesilmezse karaciğer yetmezliği, katarakt ve sepsis riski gelişebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 107: v175-new-107-yumusak-doku-enfeksiyonunda-hizla-kotulesme

Başlık: Yumuşak doku enfeksiyonunda hızla kötüleşme

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun ilk yaklaşımı seçme.

Learning Target: Nekrotizan fasiitte klinik alarm bulgularıyla acil cerrahi yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ bacakta hızla artan ağrı, şişlik ve ateş nedeniyle acile başvuruyor. Diyabet öyküsü vardır. İki gün önce sağ bacakta küçük bir kesik oluştuğunu, son 12 saatte ağrının çok şiddetlendiğini ve ciltte renk değişikliği başladığını belirtiyor.

Demografi: 58 yaşında erkek hasta | Setting: Acil serviste

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/50 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 39.3°C | Şok indeksi: 1,53 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta toksik görünümündür.
- Sağ bacakta yaygın eritem, ödem, morumsu renk değişikliği ve palpasyonla krepitasyon vardır.
- Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. (24800 /mm³). | Klinik anlam: Ağır enfeksiyon lehinedir. | Sonuç yorumu: Ağır enfeksiyon lehinedir. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. (24800 /mm³). | Yorum: Ağır enfeksiyon lehinedir. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 24800 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Ağır enfeksiyon lehinedir.

Tetkik 2: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. (5.1 mmol/L). | Klinik anlam: Doku hipoperfüzyonu ve sepsis riskini destekler. | Sonuç yorumu: Doku hipoperfüzyonu ve sepsis riskini destekler. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. (5.1 mmol/L). | Yorum: Doku hipoperfüzyonu ve sepsis riskini destekler. | Satırlar: Serum laktat / 5.1 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L / Doku hipoperfüzyonu ve sepsis riskini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral antibiyotikle ayakta izlem
- B) Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman
- C) Elektif dermatoloji kontrolü planlanması
- D) Steroid başlanarak inflamasyonun baskılanması
- E) Kesin tanı için biyopsi sonucuna göre tedavi planlanması

Doğru Cevap: Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman

A) Oral antibiyotikle ayakta izlem: Vakadaki Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir ve Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir. Bu olguda “Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman: Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman nekrotizan fasiitte kaynak kontrolü sağlayan hayat kurtarıcı yaklaşımdır. Vakadaki “Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Elektif dermatoloji kontrolü planlanması: Elektif dermatoloji kontrolü hızla ilerleyen sepsis ve doku nekrozu bulgularında tedaviyi geciktirir. Bu olguda “Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Steroid başlanarak inflamasyonun baskılanması: Steroid tedavisi enfeksiyon kontrolünü sağlamaz ve immün yanıtı baskılayarak tabloyu kötüleştirir. Bu olguda “Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kesin tanı için biyopsi sonucuna göre tedavi planlanması: Vakadaki Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir ve Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir. Bu olguda “Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yumuşak doku enfeksiyonunda hızla kötüleşme olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.” birlikte okunduğunda Acil cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman seçeneği öne çıkar; “Krepitasyon, hipotansiyon ve yüksek laktat ağır nekrotizan enfeksiyonu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Diyabetli hastada küçük travma sonrası hızla ilerleyen ağrı, toksik görünüm, hipotansiyon, krepitasyon, mor renk değişikliği ve ağrının cilt bulgularına göre orantısız olması nekrotizan fasiiti düşündürür. Tedavi antibiyotik ve resüsitasyonla birlikte gecikmeden cerrahi eksplorasyon ve geniş debridmandır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.”, “Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ve “Krepitasyon, hipotansiyon ve yüksek laktat ağır nekrotizan enfeksiyonu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil

cerrahi eksplorasyon ve geniş debridman en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Diyabet zemininde küçük cilt kesisi sonrası enfeksiyon hızla ilerlemiştir.

Kanıt 2: Ağrı cilt bulgularına göre orantısız şiddettedir.

Kanıt 3: Krepitasyon, hipotansiyon ve yüksek laktat ağır nekrotizan enfeksiyonu destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Nekrotizan fasiitte antibiyotik tek başına yeterli değildir; cerrahi debridman gecikirse mortalite artar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 108: v175-new-108-gebelikte-asiri-bulanti-ve-kanama

Başlık: Gebelikte aşırı bulantı ve kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tanıyı seçme.

Learning Target: Molar gebelikte klinik, ultrason ve beta-hCG bulgularıyla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, vajinal kanama ve aşırı bulantı-kusma nedeniyle acile başvuruyor. Son adet tarihine göre 10 haftalık gebe olduğunu, son iki haftadır gebelik haftasına göre belirgin karın büyüklüğü hissettiğini ve şiddetli bulantı-kusma yaşadığını belirtiyor. Daha önce ultrason kontrolüne gitmemiştir.

Demografi: 22 yaşında kadın hasta | Setting: Gebeliğinin 10. haftasında kadın doğum acilinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 136/86 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,79

Fizik Muayene

- Hasta hafif dehidrate görünümündedir.
- Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilir.
- Vajinal kanama az miktarda devam etmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum beta-hCG

Etiket: Serum beta-hCG | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Gebelik haftasına göre çok yüksek saptandı. (285000 mIU/mL). | Klinik anlam: Trofoblastik proliferasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Trofoblastik proliferasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Serum beta-hCG | Sonuç özeti: Gebelik haftasına göre çok yüksek saptandı. (285000 mIU/mL). | Yorum: Trofoblastik proliferasyonu destekler. | Satırlar: Serum beta-hCG / 285000 mIU/mL // Trofoblastik proliferasyonu destekler.

Tetkik 2: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Uterin kavitede embriyo izlenmedi; çok sayıda kistik boşluk içeren heterojen görünüm izlendi. | Klinik anlam: Gestasyonel trofoblastik hastalık lehine bulgudur. | Sonuç yorumu: Gestasyonel trofoblastik hastalık lehine bulgudur. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Uterin kavitede embriyo izlenmedi; çok sayıda kistik boşluk içeren heterojen görünüm izlendi. | Yorum: Gestasyonel trofoblastik hastalık lehine bulgudur. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / Uterin kavitede embriyo izlenmedi; çok sayıda kistik boşluk içeren heterojen görünüm izlendi. // Gestasyonel trofoblastik hastalık lehine bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-065 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Uterin kavitede embriyo izlenmedi; çok sayıda kistik boşluk içeren heterojen görünüm izlendi. | Klinik anlam: Gestasyonel trofoblastik hastalık lehine bulgudur. | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/065_065-komplet-mol-transvajinal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/065_065-komplet-mol-transvajinal-ultrasonografi.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Uterin kavitede embriyo izlenmedi; çok sayıda kistik boşluk içeren heterojen görünüm izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Komplet hidatidiform mol
B) Ektopik gebelik
C) Plasenta previa
D) Erken membran rüptürü
E) Uterin leiomyom dejenerasyonu

Doğru Cevap: Komplet hidatidiform mol

A) Komplet hidatidiform mol: Komplet hidatidiform mol çok yüksek beta-hCG, büyük uterus, embriyo yokluğu ve kistik uterin görünümle bu olguda en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Ektopik gebelik: Ektopik gebelikte uterin kavitede gebelik izlenmez ancak bu kadar yüksek beta-hCG, büyük uterus ve veziküler kistik görünüm tipik değildir. Bu olguda “Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Komplet hidatidiform mol seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Plasenta previa: Plasenta previa üçüncü trimesterde ağrısız kanamayla düşünülür; bu hasta erken gebelik haftasındadır. Bu olguda “Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Komplet hidatidiform mol seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Erken membran rüptürü: Erken membran rüptüründe vajinal sıvı gelişi beklenir; kistik trofoblastik uterin görünüm ve çok yüksek beta-hCG açıklanamaz. Bu olguda “Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Komplet hidatidiform mol seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Uterin leiomyom dejenerasyonu: Uterin leiomyom dejenerasyonu ağrı ve kitle etkisi yapabilir ancak beta-hCG yüksekliği ve embriyosuz veziküler uterin görünümle uyumlu değildir. Bu olguda “Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Komplet hidatidiform mol seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte aşırı bulantı ve kanama olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.” birlikte okunduğunda Komplet hidatidiform mol seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide embriyo izlenmeden çok sayıda kistik boşluk içeren görünüm saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gebeliğin erken döneminde vajinal kanama, gebelik haftasına göre büyük uterus, aşırı bulantı-kusma, çok yüksek beta-hCG ve embriyo olmadan kistik veziküler uterin görünüm komplet hidatidiform molü düşündürür. Bu tablo trofoblastik dokunun anormal proliferasyonu ile ilişkilidir. Bu olguda kararın temel

ayrımı, “Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.”, “Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.” ve “Ultrasonografide embriyo izlenmeden çok sayıda kistik boşluk içeren görünüm saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Komplet hidatidiform mol en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Uterus gebelik haftasına göre beklenenden büyük palpe edilmiştir.

Kanıt 2: Serum beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.

Kanıt 3: Ultrasonografide embriyo izlenmeden çok sayıda kistik boşluk içeren görünüm saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Komplet molde embriyo yoktur, beta-hCG belirgin yüksektir ve ultrasonografide veziküler kistik görünüm izlenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 109: v175-new-109-tiroid-ameliyati-sonrasi-ses-degisikligi

Başlık: Tiroid ameliyatı sonrası ses değişikliği

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomi yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Tiroid cerrahisi sonrası ses kısıklığını rekürren laringeal sinir hasarıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ameliyattan sonra başlayan ses kısıklığı ve konuşurken çabuk yorulma nedeniyle başvuruyor. Üç gün önce multinodeüler guatr nedeniyle total tiroidektomi geçirdiğini, ameliyattan önce ses sorunu olmadığını belirtiyor. Nefes darlığı tariflemiyor.

Demografi: 45 yaşında kadın hasta | Setting: Total tiroidektomi sonrası cerrahi kontrolünde

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta konuşurken sesi kısık ve zayıftır.
- Boyun insizyonu temizdir.
- Solunum sıkıntısı yoktur.
- Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı izlenmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma olasılığı en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus laryngeus recurrens
- B) Nervus hypoglossus
- C) Nervus glossopharyngeus
- D) Nervus accessorius
- E) Nervus phrenicus

Doğru Cevap: Nervus laryngeus recurrens

A) Nervus laryngeus recurrens: Nervus laryngeus recurrens vokal kord hareketini sağlayan larinks kaslarını innerve ettiği için tiroidektomi sonrası ses kısıklığını en iyi açıklar. Vakadaki “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Nervus hypoglossus: Nervus hypoglossus dil motor innervasyonundan sorumludur; vokal kord hareket kısıtlılığına neden olan tipik sinir değildir. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus glossopharyngeus: Nervus glossopharyngeus yutma refleksi ve farinks duyusuyla ilişkilidir; tiroid cerrahisi sonrası izole vokal kord paralizisini açıklamaz. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nervus accessorius: Nervus accessorius sternokleidomastoid ve trapezius kaslarını innerve eder; ses kısıklığı yerine omuz düşüklüğü ve baş çevirme gücü beklenir. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus phrenicus: Nervus phrenicus diyafram motor innervasyonunu sağlar; vokal kord hareket kısıtlılığı ve ses kısıklığı için en uygun sinir değildir. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tiroid ameliyatı sonrası ses değişikliği olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.” birlikte okunduğunda Nervus laryngeus recurrens seçeneği öne çıkar; “Ameliyat öncesinde ses sorunu olmadığı belirtilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tiroid cerrahisi sonrası ses kısıklığı ve tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı rekürren laringeal sinir hasarını düşündürür. Nervus laryngeus recurrens larinksin intrinsik kaslarının çoğunu innerve eder ve tiroid bezinin arka-medial komşuluğunda seyrettiği için tiroidektomide risk altındadır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.”, “Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.” ve “Ameliyat öncesinde ses sorunu olmadığı belirtilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus laryngeus recurrens en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Laringoskopide tek taraflı vokal kord hareket kısıtlılığı gösterilmiştir.

Kanıt 3: Ameliyat öncesinde ses sorunu olmadığı belirtilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Tiroidektomi sonrası ses kısıklığında ilk akla gelmesi gereken yapı nervus laryngeus recurrens'tir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 110: v175-new-110-aralikli-karin-agrisi-ve-kanli-diski

Başlık: Aralıklı karın ağrısı ve kanlı dışkı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: İnvajinasyonda klinik triad ve uygun tedavi yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, aralıklı şiddetli ağlama nöbetleri, kusma ve kanlı dışkı nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi bebeğin son 12 saattir bacaklarını karnına çekerek ağladığını, ağrı nöbetleri arasında kısa süreli sakinleştiğini belirtiyor. Son dışkısının jöle kıvamında kırmızımsı olduğu fark edilmiştir. Ateş belirgin değildir.

Demografi: 9 aylık erkek bebek | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 37.4°C | Şok indeksi: 1,50 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek huzursuzdur ve ağrı nöbetleri sırasında bacaklarını karnına çekmektedir.
- Sağ üst kadranda sosis şeklinde kitle palpe edilir; sağ alt kadranda nispeten boş hissedilir.
- Hafif dehidratasyon bulguları vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ üst kadranda hedef işareti görünümü izlendi. | Klinik anlam: Barsak segmentinin iç içe geçmesini destekler. | Sonuç yorumu: Barsak segmentinin iç içe geçmesini destekler. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sağ üst kadranda hedef işareti görünümü izlendi. | Yorum: Barsak segmentinin iç içe geçmesini destekler. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Sağ üst kadranda hedef işareti görünümü izlendi. / / Barsak segmentinin iç içe geçmesini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-066 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sağ üst kadranda hedef işareti görünümü izlendi. | Klinik anlam: Barsak segmentinin iç içe geçmesini destekler. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/066_066-intussusepsiyon-abdominal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/066_066-intussusepsiyon-abdominal-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Sağ üst kadranda hedef işareti görünümü izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Peritonit veya perforasyon bulgusu olmayan bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon
B) Geniş spektrumlu oral antibiyotikle ayaktan izlem
C) Acil apendektomi
D) Oral rehidratasyon ve yakın ayaktan izlem
E) Kontrol tedavisi olarak proton pompa inhibitörü tedavisi

Doğru Cevap: Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon

A) Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon: Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon, perforasyon ya da peritonit bulgusu olmayan invajinasyonda uygun ilk tedavidir. Vakadaki “Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır.” ve “Kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Geniş spektrumlu oral antibiyotikle ayaktan izlem: Oral antibiyotik ve ayaktan izlem mekanik barsak invajinasyonunu düzeltmez ve gecikme iskemisi riskini artırır. Bu olguda “Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır.” ve “Kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Acil apendektomi: Apendektomi akut apandisit tedavisidir; bu olguda hedef işareti ve kırmızı jöle dışkı invajinasyon lehinedir. Bu olguda “Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır ve bacakları karna çekme davranışı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral rehidratasyon ve yakın ayaktan izlem: Vakadaki Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır ve kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır.” ve “Kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kontrol tedavisi olarak proton pompa inhibitörü tedavisi: Vakadaki Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır ve kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır.” ve “Kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Aralıklı karın ağrısı ve kanlı dışkı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır.” ve “Kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide hedef işareti görünümü izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Aralıklı kolik karın ağrısı, bacakları karna çekme, kusma, kırmızı jöle kıvamlı dışkı, sosis şeklinde kitle ve ultrasonografide hedef işareti invajinasyonu düşündürür. Peritonit veya perforasyon yoksa ilk tedavi hem tanısal hem terapötik olabilen pnömatik ya da hidrostatik enema ile redüksiyondur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır.”, “Kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır.” ve “Ultrasonografide hedef işareti görünümü izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyon en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte aralıklı kolik ağrı nöbetleri ve bacakları karna çekme davranışı vardır.

Kanıt 2: Kırmızı jöle kıvamlı dışkı ve sosis şeklinde kitle saptanmıştır.

Kanıt 3: Ultrasonografide hedef işareti görünümü izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve

geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: İnvajinasyonda peritonit yoksa ilk tedavi pnömatik veya hidrostatik enema ile redüksiyondur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 111: v176-new-111-akut-kan-kaybi-sonrasi-tasikardi

Başlık: Akut kan kaybı sonrası taşikardi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Akut kan kaybında baroreseptör refleksinin kardiyovasküler yanıtlarını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacak kesisi sonrası baş dönmesi, soğuk terleme ve halsizlik nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 20 dakika önce sağ uyluğunda derin kesi olduğu ve olay yerinde belirgin miktarda kan kaybettiği öğreniliyor. Daha önce bilinen kalp hastalığı yoktur.

Demografi: 28 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/54 mmHg | Nabız: 136/dk | Solunum: 26/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,58 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk, terli ve huzursuzdur.
- Kapiller dolum süresi uzamıştır.
- Sağ uylukta bası ile kontrol altına alınan kanamalı kesi mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Başvuru anında hafif düşük saptandı. | Klinik anlam: Akut kan kaybında erken dönemde hemoglobinin gerçek kaybı tam yansıtmayabilir. | Sonuç yorumu: Akut kan kaybında erken dönemde hemoglobin gerçek kaybı tam yansıtmayabilir. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Başvuru anında hafif düşük saptandı. | Yorum: Akut kan kaybında erken dönemde hemoglobinin gerçek kaybı tam yansıtmayabilir. | Satırlar: Hemoglobin / 12.1 g/dL / 13.5-17.5 g/dL / Akut kan kaybında erken dönemde hemoglobinin gerçek kaybı tam yansıtmayabilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada kan basıncını korumaya yönelik erken fizyolojik kompanzasyonun temel mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması
B) Baroreseptör ateşlemesinin artmasıyla parasempatik aktivitenin baskın hale gelmesi
C) Atriyal natriüretik peptid salınımının artmasıyla damar direncinin yükselmesi
D) Pulmoner kemoreseptörlerin baskılanmasıyla kalp hızının azalması
E) Vagal tonusun artmasıyla sistemik vasküler direncin yükselmesi

Doğru Cevap: Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması

A) Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması: Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalması sempatik aktiviteyi artırarak taşikardi ve vazokonstriksiyon oluşturur. Vakadaki "Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir." ve "Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Baroreseptör ateşlemesinin artmasıyla parasempatik aktivitenin baskın hale gelmesi: Baroreseptör ateşlemesinin artması hipertansiyon yanıtında beklenir; akut kan kaybındaki hipotansiyon bu ateşlemeyi azaltır. Bu olguda "Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir." ve "Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Atriyal natriüretik peptid salınımının artmasıyla damar direncinin yükselmesi: Atriyal natriüretik peptid hacim fazlalığında artar ve natriürez ile vazodilatasyon eğilimi oluşturur; akut hipovolemide temel kompanzasyon değildir. Bu olguda "Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir." ve "Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pulmoner kemoreseptörlerin baskılanmasıyla kalp hızının azalması: Pulmoner kemoreseptörlerin baskılanması bu hastadaki taşikardi ve vazokonstriksiyon yanıtını açıklamaz. Bu olguda "Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir." ve "Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Vagal tonusun artmasıyla sistemik vasküler direncin yükselmesi: Vagal tonus artışı kalp hızını azaltır; akut kan kaybında vagal tonus azalır ve sempatik tonus artar. Bu olguda "Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir." ve "Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Akut kan kaybı sonrası taşikardi olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir." ve "Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir." birlikte okunduğunda Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması seçeneği öne çıkar; "Solukluk ve soğuk terleme sempatik aktivasyonla uyumludur." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Akut kan kaybı arteriyel basıncı azaltır ve karotis sinüs ile aortik ark baroreseptörlerinin gerilimini düşürür. Baroreseptör ateşlemesi azalınca medüller merkezler sempatik çıkışı artırır, parasempatik tonusu azaltır; taşikardi, kontraktileite artışı ve periferik vazokonstriksiyon gelişerek kan basıncı desteklenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir.", "Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir." ve "Solukluk ve soğuk terleme sempatik aktivasyonla uyumludur." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Karotis sinüs ve aortik ark baroreseptör ateşlemesinin azalmasıyla sempatik aktivitenin artması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada kısa sürede belirgin kan kaybı gelişmiştir.

Kanıt 2: Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum düşük efektif dolaşım hacmini gösterir.

Kanıt 3: Solukluk ve soğuk terleme sempatik aktivasyonla uyumludur.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Akut hipotansiyonda baroreseptör ateşlemesi azalır; kompanzasyon sempatik aktivite artışı ve vagal tonus azalmasıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 112: v176-new-112-asidozda-derin-hizli-solunum

Başlık: Asidozda derin hızlı solunum

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Metabolik asidozda solunumsal kompanzasyonun yönünü ve mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, halsizlik, bulantı ve derin hızlı solunum nedeniyle acile başvuruyor. Tip 1 diyabet öyküsü vardır. Son iki gündür insülin dozlarını aksattığını, çok su içtiğini ve sık idrara çıktığını belirtiyor. Ateş veya öksürük tariflemiyor.

Demografi: 19 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 98/62 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,20 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta dehidrate görünümündedir.
- Derin ve düzenli hızlı solunum paterni izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz ve solunumsal kompanzasyon saptandı. | Klinik anlam: Primer metabolik asidoza düşük karbondioksit eşlik etmektedir. | Sonuç yorumu: Primer metabolik asidoza düşük karbondioksit eşlik etmektedir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz ve solunumsal kompanzasyon saptandı. | Yorum: Primer metabolik asidoza düşük karbondioksit eşlik etmektedir. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.18, HCO₃ 9, PaCO₂ 24 mmol/L ve mmHg / pH 7.35-7.45, HCO₃ 22-26 mmol/L, PaCO₂ 35-45 mmHg / Primer metabolik asidoza düşük karbondioksit eşlik etmektedir.

Tetkik 2: Serum glukoz

Etiket: Serum glukoz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Diyabetik ketoasidoz tablosunu destekler. | Sonuç yorumu: Diyabetik ketoasidoz tablosunu destekler. | Sonuç başlığı: Serum glukoz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Diyabetik ketoasidoz tablosunu destekler. | Satırlar: Serum glukoz / 486 mg/dL / 70-140 mg/dL / Diyabetik ketoasidoz tablosunu destekler.

Tetkik 3: Serum ketonu

Etiket: Serum ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Ketotik metabolik asidozu destekler. | Sonuç yorumu: Ketotik metabolik asidozu destekler. | Sonuç başlığı: Serum ketonu | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Ketotik metabolik asidozu destekler. | Satırlar: Serum ketonu / Pozitif saptandı. // Ketotik metabolik asidozu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-279 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Derin ve düzenli hızlı solunum paterni izlenir. | Klinik anlam: Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/279_patient_in_hospital_bed_with_monitoring_equipment.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/279_patient_in_hospital_bed_with_monitoring_equipment.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Derin ve düzenli hızlı solunum paterni izlenir. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki derin hızlı solunumun temel fizyolojik amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak
- B) Bikarbonat üretimini akciğerde doğrudan artırmak
- C) Karbondioksit tutulumu oluşturarak solunumsal asidoz eklemek
- D) Oksijen tüketimini tamamen durdurarak laktat üretimini kesmek
- E) Böbrekten keton atılımını solunum yoluyla doğrudan artırmak

Doğru Cevap: Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak

A) Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak: Karbondioksit atılımının artması metabolik asidozda pH düşüşünü sınırlayan temel solunumsal kompanzasyondur. Vakadaki “Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.” ve “PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Bikarbonat üretimini akciğerde doğrudan artırmak: Akciğer bikarbonatı doğrudan üretmez; bikarbonat dengesi esas olarak böbrek ve tampon sistemleriyle ilişkilidir. Bu olguda “Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.” ve “PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.” ipuçları klinik karar açısından Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Karbondioksit tutulumu oluşturarak solunumsal asidoz eklemek: Karbondioksit tutulumu pH değerini daha da düşürür ve metabolik asidozu kompanse etmek yerine ağırlaştırır. Bu olguda “Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.” ve “PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.” ipuçları klinik karar açısından Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oksijen tüketimini tamamen durdurarak laktat üretimini kesmek: Solunum artışı oksijen tüketimini tamamen durdurmaz; temel amaç karbondioksit basıncını azaltmaktır. Bu olguda “Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.” ve “PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.” ipuçları klinik karar açısından Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Böbrekten keton atılımını solunum yoluyla doğrudan artırmak: Ketonların atılımı solunum yoluyla doğrudan gerçekleşmez; solunumsal kompanzasyon karbondioksit üzerinden olur. Bu olguda “Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.” ve “PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.” ipuçları klinik karar açısından Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Asidozda derin hızlı solunum olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.” ve “PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.” birlikte okunduğunda Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak seçeneği öne çıkar; “Hastada derin hızlı solunum paterni izlenmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada primer bozukluk düşük bikarbonatla seyreden metabolik asidozdur. Periferik ve santral kemoreseptör yanıtları ventilasyonu artırır; karbondioksit atılımı artınca PaCO₂ düşer ve Henderson-Hasselbalch ilişkisi üzerinden pH düşüşü kısmen kompanse edilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.”, “PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.” ve “Hastada derin hızlı solunum paterni izlenmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Karbondioksit atılımını artırarak pH düşüşünü kısmen sınırlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Arter kan gazında pH ve bikarbonat düşük saptanmıştır.

Kanıt 2: PaCO₂ düşüklüğü solunumsal kompanzasyonu göstermektedir.

Kanıt 3: Hastada derin hızlı solunum paterni izlenmektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Metabolik asidozda solunumsal kompanzasyon hiperventilasyonla PaCO₂ düşürmektir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 113: v176-new-113-antikoagulan-kullanırken-ciddi-kanama

Başlık: Antikoagülan kullanırken ciddi kanama

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Warfarin toksisitesinde kanama şiddetine göre uygun geri çevirme tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, siyah dışkılama, halsizlik ve baş dönmesi nedeniyle acile başvuruyor. Atriyal fibrilasyon nedeniyle warfarin kullandığı, son hafta üst solunum yolu enfeksiyonu için antibiyotik aldığı öğreniliyor. Son iki gündür melena tarifliyor ve bugün ayağa kalkınca bayılacak gibi olduğunu belirtiyor.

Demografi: 74 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 84/50 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,48 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve terli görünümündedir.
- Rektal muayenede melena vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: INR

Etiket: INR | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aşırı antikoagülasyonu gösterir. | Sonuç yorumu: Aşırı antikoagülasyonu gösterir. | Sonuç başlığı: INR | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Aşırı antikoagülasyonu gösterir. | Satırlar: INR / 8.6 / 2.0-3.0 tedavi aralığı / Aşırı antikoagülasyonu gösterir.

Tetkik 2: Hemogloblin

Etiket: Hemogloblin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Klinik olarak anlamlı kan kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Klinik olarak anlamlı kan kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Hemogloblin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Klinik olarak anlamlı kan kaybını destekler. | Satırlar: Hemogloblin / 7.4 g/dL / 13.5-17.5 g/dL / Klinik olarak anlamlı kan kaybını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada warfarin etkisini acilen geri çevirmek için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Warfarine aynı dozda devam edilmesi
- B) Düşük doz oral K vitamini verilmesi ve ayaktan izlem
- C) İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi
- D) Protamin sülfat verilmesi
- E) Asetilsalisilik asit eklenmesi

Doğru Cevap: İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi

A) Warfarine aynı dozda devam edilmesi: Vakadaki Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir ve INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir. Bu olguda “Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.” ve “INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Düşük doz oral K vitamini verilmesi ve ayaktan izlem: Vakadaki Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir ve INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir. Bu olguda “Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.” ve “INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi: İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi majör warfarin kanamasında hem hızlı hem kalıcı geri çevirme sağlar. Vakadaki “Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.” ve “INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

D) Protamin sülfat verilmesi: Protamin sülfat heparin etkisini geri çevirmek için kullanılır; warfarinle azalmış K vitamini bağımlı faktörleri hızla yerine koymaz. Bu olguda “Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Asetilsalisilik asit eklenmesi: Asetilsalisilik asit trombosit fonksiyonunu bozarak kanama riskini artırır ve bu tabloda uygun değildir. Bu olguda “Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.” ve “INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antikoagülan kullanırken ciddi kanama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.” ve “INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir.” birlikte okunduğunda İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneği öne çıkar; “Hemogloblin düşüklüğü aktif veya yakın dönem ciddi kan kaybını destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu hastada warfarin kullanımı sırasında çok yüksek INR, melena, hipotansiyon ve belirgin anemi yaşamı tehdit eden majör kanamayı gösterir. Acil geri çevirme için warfarin kesilir, intravenöz K vitamini uzun süreli düzeltme sağlar ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi hızlı pıhtılaşma faktörü replasmanı yapar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.”, “INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir.” ve “Hemogloblin düşüklüğü aktif veya yakın dönem ciddi kan kaybını destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz K vitamini ve dört faktörlü protrombin kompleks konsantresi verilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta warfarin kullanırken melena ve hemodinamik instabilite geliştirmiştir.

Kanıt 2: INR değeri tedavi aralığının belirgin üzerindedir.

Kanıt 3: Hemogloblin düşüklüğü aktif veya yakın dönem ciddi kan kaybını destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağına yerine geçmez.

Exam Pearl: Warfarin ilişkili majör kanamada hızlı geri çevirme için protrombin kompleks konsantresi ve intravenöz K vitamini birlikte kullanılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 114: v176-new-114-gorme-degisikligi-ve-aritmi

Başlık: Görme değişikliği ve aritmi

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Digoksin toksisitesinde klinik bulgular ve antidot kullanımını ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bulantı, görmede sarı-yeşil renklenme ve çarpıntı nedeniyle acile başvuruyor. Kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon nedeniyle digoksin kullandığı öğreniliyor. Son günlerde iştahsızlık nedeniyle az beslendiğini ve idrar söktürücü dozunun artırıldığını belirtiyor.

Demografi: 79 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 102/64 mmHg | Nabız: 46/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,45

Fizik Muayene

- Hasta halsiz görünümündedir.
- Bilinci açıktır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ciddi digoksin toksisitesi açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Ciddi digoksin toksisitesi açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Ciddi digoksin toksisitesi açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Serum potasyum / 5.9 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Ciddi digoksin toksisitesi açısından uyarıcıdır.

Tetkik 2: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve ventriküler ektopiler izlendi. | Klinik anlam: İlaç toksisitesine bağlı ritim bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: İlaç toksisitesine bağlı ritim bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve ventriküler ektopiler izlendi. | Yorum: İlaç toksisitesine bağlı ritim bozukluğunu destekler. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve ventriküler ektopiler izlendi. // İlaç toksisitesine bağlı ritim bozukluğunu destekler.

Tetkik 3: Serum digoksin düzeyi

Etiket: Serum digoksin düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Toksik düzeyi destekler. | Sonuç yorumu: Toksik düzeyi destekler. | Sonuç başlığı: Serum digoksin düzeyi | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Toksik düzeyi destekler. | Satırlar: Serum digoksin düzeyi / 4.1 ng/mL / 0.5-2.0 ng/mL / Toksik düzeyi destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-067 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve ventriküler ektopiler izlendi. | Klinik anlam: İlaç toksisitesine bağlı ritim bozukluğunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/067_067-digoksin-toksitesitesi-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/067_067-digoksin-toksitesitesi-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve ventriküler ektopiler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun spesifik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Digoksin immün Fab antikorü
- B) Nalokson
- C) Vitamin K
- D) Pralidoksim
- E) Flumazenil

Doğru Cevap: Digoksin immün Fab antikorü

A) Digoksin immün Fab antikorü: Digoksin immün Fab antikorü toksik digoksini bağlayarak ciddi aritmi ve hiperkalemiyle seyreden tabloda spesifik tedavi sağlar. Vakadaki "Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır." ve "Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Nalokson: Nalokson opioid toksisitesinde kullanılır; digoksin kaynaklı aritmi ve renk görme bozukluğunu düzeltmez. Bu olguda "Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır." ve "Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin immün Fab antikorü seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Vitamin K: Vitamin K warfarin etkisini geri çevirmek için kullanılır; digoksin toksisitesinde spesifik antidot değildir. Bu olguda "Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır." ve "Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin immün Fab antikorü seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pralidoksim: Pralidoksim organofosfat zehirlenmesinde asetilkolinesteraz reaktivasyonu sağlar; digoksin etkisini bağlamaz. Bu olguda "Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır." ve "Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin immün Fab antikorü seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Flumazenil: Flumazenil benzodiazepin antagonisti olarak etki eder; digoksin toksisitesindeki kardiyak bulgulara yönelik değildir. Bu olguda "Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır." ve "Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin immün Fab antikorü seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Görme değişikliği ve aritmi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır." ve "Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır." birlikte okunduğunda Digoksin immün Fab antikorü seçeneği öne çıkar; "Bradikardi, ventriküler ektopiler ve hiperkalemi ciddi toksisiteyi destekler." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bulantı, renk görme bozukluğu, bradikardi, ventriküler ektopiler, yüksek digoksin düzeyi ve hiperkalemi digoksin toksisitesini düşündürür. Ciddi aritmi veya hiperkalemi varlığında spesifik tedavi digoksini bağlayan immün Fab antikorüdür. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır.", "Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır." ve "Bradikardi, ventriküler ektopiler ve hiperkalemi ciddi toksisiteyi destekler." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesi; bu nedenle Digoksin immün Fab antikorü en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada digoksin kullanımı öyküsü ve yüksek serum digoksin düzeyi vardır.

Kanıt 2: Görmede sarı-yeşil renklenme ve bulantı digoksin toksisitesinin tipik bulgularıdır.

Kanıt 3: Bradikardi, ventriküler ektopiler ve hiperkalemi ciddi toksisiteyi destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Digoksin toksisitesinde hayatı tehdit eden aritmi veya hiperkalemi varsa digoksin immün Fab kullanılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 115: v176-new-115-kronik-inflamasyon-sonrasi-proteinuri

Başlık: Kronik inflamasyon sonrası proteinüri

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Amiloidozda Kongo kırmızısı boyanma özelliğini ve nefrotik tabloyu ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacaklarda şişlik ve idrarda köpüklenme nedeniyle başvuruyor. Uzun yıllardır romatoid artrit nedeniyle takip edildiği ve dönem dönem yüksek inflamasyon bulguları olduğu öğreniliyor. Son aylarda yorgunluk, kilo kaybı ve giderek artan ödem tarifliyor.

Demografi: 63 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 132/78 mmHg | Nabız: 86/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,65

Fizik Muayene

- Bilateral pretibial gode bırakan ödem vardır.
- Eklem deformiteleri mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: 24 saatlik idrar protein düzeyi

Etiket: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Klinik anlam: Glomerüler protein kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Glomerüler protein kaybını destekler. | Sonuç başlığı: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Sonuç özeti: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Yorum: Glomerüler protein kaybını destekler. | Satırlar: 24 saatlik idrar protein düzeyi / 7.1 g/gün / <0.15 g/gün / Glomerüler protein kaybını destekler.

Tetkik 2: Serum albümin

Etiket: Serum albümin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Nefrotik sendromla uyumludur. | Sonuç yorumu: Nefrotik sendromla uyumludur. | Sonuç başlığı: Serum albümin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Nefrotik sendromla uyumludur. | Satırlar: Serum albümin / 2.4 g/dL / 3.5-5.0 g/dL / Nefrotik sendromla uyumludur.

Tetkik 3: Böbrek biyopsisi

Etiket: Böbrek biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Glomerüllerde amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlendi. | Klinik anlam: Depolanma hastalığı olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Depolanma hastalığı olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Böbrek biyopsisi | Sonuç özeti: Glomerüllerde amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlendi. | Yorum: Depolanma hastalığı olasılığını destekler. | Satırlar: Böbrek biyopsisi / Glomerüllerde amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlendi. / / Depolanma hastalığı olasılığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-068 | Başlık: Böbrek biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Glomerüllerde amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlendi. | Klinik anlam: Depolanma hastalığı olasılığını destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/068_068-amiloidoz-bobrek-biyopsisi-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/068_068-amiloidoz-bobrek-biyopsisi-histopatoloji.webp | Alt text: Böbrek biyopsisi - Glomerüllerde amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-280 | Başlık: Fizik muayene bulgusu | Modalite: clinical | Bulgu: Eklem deformiteleri mevcuttur. | Klinik anlam: Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/280_elderly_hands_with_arthritis_deformities.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/280_elderly_hands_with_arthritis_deformities.webp | Alt text: Fizik muayene bulgusu - Eklem deformiteleri mevcuttur. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada tanıyı destekleyen karakteristik boyanma bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma
B) Ziehl-Neelsen ile aside dirençli basil görülmesi
C) Prusya mavisini ile demir birikimi
D) PAS ile fungal hiflerin gösterilmesi
E) Gümüş boyası ile glomerüler bazal membranda spike görünümü

Doğru Cevap: Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma

A) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma: Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma amiloid birikimini gösteren karakteristik histokimyasal bulgudur. Vakadaki “Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.” ve “Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Ziehl-Neelsen ile aside dirençli basil görülmesi: Ziehl-Neelsen ile aside dirençli basil tüberküloz gibi mikobakteriyel enfeksiyonları gösterir; amiloid depolanmasını tanımlamaz. Bu olguda “Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.” ve “Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Prusya mavisini ile demir birikimi: Prusya mavisini demir birikimini gösterir; amorf eozinofilik amiloid birikiminin karakteristik boyası değildir. Bu olguda “Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.” ve “Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.

D) PAS ile fungal hiflerin gösterilmesi: PAS ile fungal hifler bazı mantar enfeksiyonlarında gösterilebilir; nefrotik sendromla seyreden amiloid birikimini açıklamaz. Bu olguda “Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.” ve “Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Gümüş boyası ile glomerüler bazal membranda spike görünümü: Gümüş boyasıyla spike görünümü membranöz nefropatide beklenir; kronik inflamasyon zeminindeki amiloid birikimi için en karakteristik bulgu değildir. Bu olguda “Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.” ve “Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik inflamasyon sonrası proteinüri olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.” ve “Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneği öne çıkar; “Biyopside amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik inflamatuvar hastalık zemininde gelişen nefrotik sendrom ve glomerüllerde amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim sekonder amiloidozu düşündürür. Amiloid birikimi Kongo kırmızısı ile boyanır ve polarize ışık altında elma yeşili çift kırılma gösterir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.”, “Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.” ve “Biyopside amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada uzun süreli romatoid artrit ve kronik inflamasyon öyküsü vardır.

Kanıt 2: Nefrotik düzey proteinüri ve hipoalbuminemi saptanmıştır.

Kanıt 3: Biyopside amorf eozinofilik ekstrasellüler birikim izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Amiloid Kongo kırmızısı ile boyanır ve polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılma gösterir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 116: v176-new-116-gogus-agrisi-sonrasi-ani-kotulesme

Başlık: Göğüs ağrısı sonrası ani kötüleşme

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Akut miyokard enfarktüsünde zamanla gelişen histopatolojik değişiklikleri ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, uzun süren göğüs ağrısı sonrası bilinç kaybı gelişmesi nedeniyle acile getiriliyor. Yakınları hastanın yaklaşık 24 saat önce başlayan baskı tarzında göğüs ağrısı olduğunu ancak hastaneye başvurmamış olduğunu belirtiyor. Hipertansiyon ve sigara öyküsü vardır.

Demografi: 60 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 90/56 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,31 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta entübedir.
- Cilt soluk ve soğuktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: Akut transmural iskemi lehinedir. | Sonuç yorumu: Akut transmural iskemi lehinedir. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Yorum: Akut transmural iskemi lehinedir. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. // Akut transmural iskemi lehinedir.

Tetkik 2: Troponin I

Etiket: Troponin I | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Miyokard hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Miyokard hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Troponin I | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Miyokard hasarını destekler. | Satırlar: Troponin I / 18.6 ng/mL / <0.04 ng/mL / Miyokard hasarını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-069 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: Akut transmural iskemi lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/069_069-anterior-stemi-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/069_069-anterior-stemi-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada enfarktüs bölgesinde yaklaşık 24 saatlik süreçte beklenen baskın histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması
B) Yoğun makrofaj infiltrasyonu ve yumuşak sarı nekrotik alan
C) Kollajen ağırlıklı yoğun skar dokusu
D) Tamamen normal ışık mikroskopik görünüm
E) Granülatöz inflamasyon ve kazeöz nekroz

Doğru Cevap: Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması

A) Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması: Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması yaklaşık 24 saatlik miyokard enfarktüsünde beklenen baskın histolojik bulgudur. Vakadaki "Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır." ve "Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Yoğun makrofaj infiltrasyonu ve yumuşak sarı nekrotik alan: Yoğun makrofaj infiltrasyonu ve yumuşak sarı nekrotik alan genellikle birkaç gün sonra belirginleşir. Bu olguda "Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır." ve "Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Kollajen ağırlıklı yoğun skar dokusu: Kollajen ağırlıklı skar dokusu haftalar içinde gelişir; 24 saatlik akut enfarktüs için erken bir bulgu değildir. Bu olguda "Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır." ve "Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Tamamen normal ışık mikroskopik görünüm: Tamamen normal ışık mikroskopik görünüm çok erken saatlerde olabilir; 24 saatlik süreçte nekroz ve nötrofil yanıtı beklenir. Bu olguda "Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır." ve "Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Granülatöz inflamasyon ve kazeöz nekroz: Granülatöz inflamasyon ve kazeöz nekroz tüberküloz gibi kronik granülatöz hastalıkları düşündürür; akut miyokard enfarktüsünün paterni değildir. Bu olguda "Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır." ve "Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Göğüs ağrısı sonrası ani kötüleşme olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır." ve "Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir." birlikte okunduğunda Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması seçeneği öne çıkar; "Troponin I belirgin yüksek saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Göğüs ağrısının yaklaşık 24 saat önce başlaması ve ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü bulguları enfarktüsün erken histolojik dönemini düşündürür. Bu dönemde miyositlerde koagülasyon nekrozu belirginleşir ve nötrofil infiltrasyonu başlar; makrofaj baskınlığı daha sonraki günlerde gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır.", "Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir." ve "Troponin I belirgin yüksek saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Koagülasyon nekrozu ve nötrofil infiltrasyonunun başlaması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Göğüs ağrısı yaklaşık 24 saat önce başlamıştır.

Kanıt 2: Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir.

Kanıt 3: Troponin I belirgin yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Miyokard enfarktüsünde ilk 1-3 günde koagülasyon nekrozu ve nötrofiller; 3-7 günde makrofajlar belirgindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 117:

v176-new-117-yenidoganda-beslenme-bozulmasi-ve-ozel-idrar-kokusu

Başlık: Yenidoğanda beslenme bozulması ve özel idrar kokusu

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Akçaağaç şurubu idrar hastalığında dallı zincirli amino asit metabolizması defektini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, emmede azalma, letarji ve idrarda tatlımsı koku nedeniyle getiriliyor. Doğumdan sonraki ilk günlerde iyi olduğu, son iki gündür emmesinin azaldığı, kusmalarının başladığı ve giderek uykuya eğilimli hale geldiği öğreniliyor. Ailede akraba evliliği vardır.

Demografi: 6 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirmesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 158/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,26 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve hipotoniktir.
- Aralıklı iritabilite ve tiz ağlama izlenir.
- Belirgin hepatomegali yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma amino asit analizi

Etiket: Plazma amino asit analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lösin, izölösin ve valin düzeylerinde belirgin artış saptandı. | Klinik anlam: Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma amino asit analizi | Sonuç özeti: Lösin, izölösin ve valin düzeylerinde belirgin artış saptandı. | Yorum: Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Plazma amino asit analizi / Lösin, izölösin ve valin düzeylerinde belirgin artış saptandı. // Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: İdrar organik asit analizi

Etiket: İdrar organik asit analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Dallı zincirli ketoasit metabolitleri arttı. | Klinik anlam: Katabolizma basamağındaki blokla uyumludur. | Sonuç yorumu: Katabolizma basamağındaki blokla uyumludur. | Sonuç başlığı: İdrar organik asit analizi | Sonuç özeti: Dallı zincirli ketoasit metabolitleri arttı. | Yorum: Katabolizma basamağındaki blokla uyumludur. | Satırlar: İdrar organik asit analizi / Dallı zincirli ketoasit metabolitleri arttı. // Katabolizma basamağındaki blokla uyumludur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki temel biyokimyasal defekt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği
B) Phenylalanine hydroxylase eksikliği
C) Homogentisate oxidase eksikliği
D) Cystathionine beta-synthase eksikliği
E) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği

Doğru Cevap: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği

- A) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği lösin, izölösin ve valin birikimiyle bu yenidoğan tablosunu açıklar. Vakadaki “Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- B) Phenylalanine hydroxylase eksikliği: Phenylalanine hydroxylase eksikliği fenilketonüriye yol açar; dallı zincirli amino asit artışıyla uyumlu değildir. Bu olguda “Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Homogentisate oxidase eksikliği: Homogentisate oxidase eksikliği alkaptonüri yapar; yenidoğanda tatlımsı idrar kokusu ve lösin artışıyla açıklamaz. Bu olguda “Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Cystathionine beta-synthase eksikliği: Cystathionine beta-synthase eksikliği homosistinüriye neden olur; tromboz ve lens subluksasyonu beklenir. Bu olguda “Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği klasik galaktozemiyle ilişkilidir; sütle beslenme sonrası hepatik etkilenim ve katarakt ön plandadır. Bu olguda “Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda beslenme bozulması ve özel idrar kokusu olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.” birlikte okunduğunda Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği seçeneği öne çıkar; “Plazmada lösin, izölösin ve valin düzeyleri belirgin yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda beslenme bozukluğu, letarji, nörolojik bulgular, tatlımsı idrar kokusu ve lösin-izölösin-valin artışı akçaağaç şurubu idrar hastalığını düşündürür. Temel defekt dallı zincirli alfa-ketoasit dehidrogenaz kompleksindedir; dallı zincirli amino asitler ve ketoasitleri birikir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.”, “İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.” ve “Plazmada lösin, izölösin ve valin düzeyleri belirgin yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase kompleks eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte yenidoğan döneminde emmede azalma, letarji ve nörolojik bulgular gelişmiştir.

Kanıt 2: İdrarda tatlımsı koku fark edilmiştir.

Kanıt 3: Plazmada lösin, izölösin ve valin düzeyleri belirgin yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Akçaağaç şurubu idrar hastalığında dallı zincirli amino asitler olan lösin, izölösin ve valin birikir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 118: v176-new-118-ilac-sonrasi-koyu-idrar-ve-sarilik

Başlık: İlaç sonrası koyu idrar ve sarılık

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: G6PD eksikliğinde oksidatif stres sonrası hemoliz mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, koyu renkli idrar, halsizlik ve gözlerde sararma nedeniyle başvuruyor. İki gün önce enfeksiyon nedeniyle yeni bir ilaç başladığını ve sonrasında halsizlik ile sırt ağrısı geliştiğini belirtiyor. Daha önce bakla yedikten sonra benzer ancak daha hafif bir atak yaşadığını ifade ediyor.

Demografi: 22 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,96 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve hafif ikteriktir.
- Skleralarda sararma vardır.
- Dalak belirgin palpabl değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Akut anemiyi destekler. | Sonuç yorumu: Akut anemiyi destekler. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Akut anemiyi destekler. | Satırlar: Hemoglobin / 8.9 g/dL / 13.5-17.5 g/dL / Akut anemiyi destekler.

Tetkik 2: İndirekt bilirubin

Etiket: İndirekt bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hemolizi destekler. | Sonuç yorumu: Hemolizi destekler. | Sonuç başlığı: İndirekt bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hemolizi destekler. | Satırlar: İndirekt bilirubin / 3.8 mg/dL / 0.2-0.8 mg/dL / Hemolizi destekler.

Tetkik 3: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Isırık hücreleri ve Heinz cisimcikleri izlendi. | Klinik anlam: Oksidatif eritrosit hasarını düşündürür. | Sonuç yorumu: Oksidatif eritrosit hasarını düşündürür. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Isırık hücreleri ve Heinz cisimcikleri izlendi. | Yorum: Oksidatif eritrosit hasarını düşündürür. | Satırlar: Periferik yayma / Isırık hücreleri ve Heinz cisimcikleri izlendi. / / Oksidatif eritrosit hasarını düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-070 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Isırık hücreleri ve Heinz cisimcikleri izlendi. | Klinik anlam: Oksidatif eritrosit hasarını düşündürür. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/070_070-g6pd-eksikligi-periferik-yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/070_070-g6pd-eksikligi-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Isırık hücreleri ve Heinz cisimcikleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hemolizin temel biyokimyasal mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi
- B) Heme sentezinde ferroşelataz aktivitesinin artması
- C) Globin zincir sentezinin tamamen durması
- D) Vitamin B12 emiliminin azalmasına bağlı DNA sentez kusuru
- E) Demirin makrofajlardan salınımının hepsidin azalmasıyla artması

Doğru Cevap: NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi

A) NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi: NADPH üretiminin azalması indirgenmiş glutatyon yenilenmesini bozarak oksidatif stres sonrası eritrosit hemolizine yol açar. Vakadaki “Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.” ve “Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Heme sentezinde ferroşelataz aktivitesinin artması: Ferroşelataz aktivitesinin artması bu hemolitik tabloyu açıklamaz; heme sentez bozuklukları farklı klinik paternler oluşturur. Bu olguda “Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.” ve “Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Globin zincir sentezinin tamamen durması: Globin zincir sentezinin tamamen durması talasemi gibi hemoglobin sentez bozukluklarını düşündürür; oksidatif atak ve Heinz cisimcikleriyle uyumlu değildir. Bu olguda “Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.” ve “Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Vitamin B12 emiliminin azalmasına bağlı DNA sentez kusuru: Vitamin B12 emilim azalması megaloblastik anemi yapar; akut oksidatif hemoliz ve isırık hücreleri beklenmez. Bu olguda “Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.” ve “Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Demirin makrofajlardan salınımının hepsidin azalmasıyla artması: Hepsidin azalması demir metabolizmasıyla ilişkilidir; oksidatif eritrosit membran hasarının temel nedeni değildir. Bu olguda “Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.” ve “Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: İlaç sonrası koyu idrar ve sarılık olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.” ve “Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.” birlikte okunduğunda NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneği öne çıkar; “Periferik yaymada Heinz cisimcikleri ve isırık hücreleri görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Oksidatif ilaç veya bakla maruziyeti sonrası gelişen akut hemoliz, koyu idrar, indirekt bilirubin yüksekliği, Heinz cisimcikleri ve isırık hücreleri G6PD eksikliğini düşündürür. G6PD eksikliğinde pentoz fosfat yolundan NADPH üretimi azalır; indirgenmiş glutatyon yenilenemez ve eritrositler oksidatif hasara duyarlı hale gelir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.”, “Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.” ve “Periferik yaymada Heinz cisimcikleri ve isırık hücreleri görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle NADPH üretiminin azalması nedeniyle indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hemolitik atak oksidatif ilaç maruziyetinden sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Daha önce bakla sonrası benzer atak öyküsü vardır.

Kanıt 3: Periferik yaymada Heinz cisimcikleri ve isırık hücreleri görülmüştür.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: G6PD eksikliğinde sorun NADPH yetersizliği ve glutatyonun indirgenmiş halde tutulamamasıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 119: v176-new-119-kamp-sonrasi-kotu-kokulu-ishal

Başlık: Kamp sonrası kötü kokulu ishal

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Giardia enfeksiyonunda malabsorptif ishal ve tanısal bulguları ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, iki haftadır süren kötü kokulu ishal ve karında şişkinlik nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık üç hafta önce dağ kampına gittiğini ve dere suyunu yeterince kaynatmadan içtiğini belirtiyor. Dışkılarının yağlı, kötü kokulu ve su yüzeyinde kalma eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Ateş ve kanlı dışkılama tariflemiyor.

Demografi: 24 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Hasta hafif kilo kaybetmiş görünmektedir.
- Batında yaygın hafif distansiyon vardır, defans veya rebound yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Dışkı antijen testi

Etiket: Dışkı antijen testi | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Giardia antijeni pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni destekler. | Sonuç yorumu: Etkeni destekler. | Sonuç başlığı: Dışkı antijen testi | Sonuç özeti: Giardia antijeni pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni destekler. | Satırlar: Dışkı antijen testi / Giardia antijeni pozitif saptandı. // Etkeni destekler.

Tetkik 2: Dışkı mikroskopisi

Etiket: Dışkı mikroskopisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Armut şekilli, iki çekirdekli trofozoitlerle uyumlu yapılar görüldü. | Klinik anlam: Protozoal etkenin morfolojik ipucudur. | Sonuç yorumu: Protozoal etkenin morfolojik ipucudur. | Sonuç başlığı: Dışkı mikroskopisi | Sonuç özeti: Armut şekilli, iki çekirdekli trofozoitlerle uyumlu yapılar görüldü. | Yorum: Protozoal etkenin morfolojik ipucudur. | Satırlar: Dışkı mikroskopisi / Armut şekilli, iki çekirdekli trofozoitlerle uyumlu yapılar görüldü. // Protozoal etkenin morfolojik ipucudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-071 | Başlık: Dışkı mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Armut şekilli, iki çekirdekli trofozoitlerle uyumlu yapılar görüldü. | Klinik anlam: Protozoal etkenin morfolojik ipucudur. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/071_071-giardia-trofozoitleri-diski-mikroskopisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/071_071-giardia-trofozoitleri-diski-mikroskopisi.webp | Alt text: Dışkı mikroskopisi - Armut şekilli, iki çekirdekli trofozoitlerle uyumlu yapılar görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Entamoeba histolytica
B) Giardia lamblia
C) Cryptosporidium parvum
D) Cyclospora cayetanensis
E) Balantidium coli

Doğru Cevap: Giardia lamblia

- A) Entamoeba histolytica: Entamoeba histolytica kanlı dizanteri ve karaciğer apsesiyle ilişkilidir; bu olguda kansız yağlı ishal ön plandadır. Bu olguda “Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.” ve “Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Giardia lamblia seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Giardia lamblia: Giardia lamblia kaynatılmamış su maruziyeti sonrası yağlı kötü kokulu ishal ve iki çekirdekli armut şekilli trofozoitlerle en uyumludur. Vakadaki “Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.” ve “Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- C) Cryptosporidium parvum: Cryptosporidium parvum özellikle immünsüpresyonda sulu ishal yapar; yağlı malabsorptif dışkı ve Giardia antijen pozitifliği bu seçeneği geri plana iter. Bu olguda “Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.” ve “Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Giardia lamblia seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Cyclospora cayetanensis: Cyclospora cayetanensis uzamış sulu ishal yapabilir ancak verilen morfoloji ve antijen testi Giardia lehinedir. Bu olguda “Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.” ve “Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Giardia lamblia seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Balantidium coli: Balantidium coli domuz teması ve dizanteriyle ilişkilidir; bu hastadaki su kaynaklı yağlı ishal paternini açıklamaz. Bu olguda “Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.” ve “Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Giardia lamblia seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kamp sonrası kötü kokulu ishal olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.” ve “Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.” birlikte okunduğunda Giardia lamblia seçeneği öne çıkar; “Dışkı antijen testi Giardia için pozitif bulunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kaynatılmamış dere suyu sonrası gelişen kötü kokulu yağlı ishal, karında şişkinlik, ateş ve kan olmaması Giardia lamblia enfeksiyonunu düşündürür. Giardia duodenum ve jejunum mukozasına tutunarak yağ emilimini bozar ve malabsorptif ishal oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.”, “Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.” ve “Dışkı antijen testi Giardia için pozitif bulunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Giardia lamblia en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hasta kamp sırasında kaynatılmamış dere suyu içmiştir.

Kanıt 2: Dışkı yağlı, kötü kokulu ve malabsorptif özellikte tarifiyenmiştir.

Kanıt 3: Dışkı antijen testi Giardia için pozitif bulunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Giardia enfeksiyonu kirli su sonrası yağlı, kötü kokulu ve kansız ishal yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 120: v176-new-120-diskilama-sonrasi-anal-agri

Başlık: Dışkılama sonrası anal ağrı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Akut anal fissürde ağrı ve kanama paternine göre tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, dışkılama sırasında başlayan şiddetli anal ağrı ve tuvalet kâğıdında parlak kırmızı kan nedeniyle başvuruyor. Son haftalarda kabızlık yaşadığını ve sert dışkılama sonrası cam kesiği gibi ağrı başladığını belirtiyor. Ağrı dışkılama sonrasında bir süre devam etmektedir. Kilo kaybı, ateş veya sürekli ishal tariflemiyor.

Demografi: 31 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Perianal inspeksiyonda posterior orta hatta yüzeyel lineer yırtık izlenir.
- Dijital rektal muayene ağrı nedeniyle sınırlıdır.
- Belirgin perianal fluktuasyon yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut anal fissür
- B) Perianal apse
- C) Rektum kanseri
- D) İnternal hemoroid trombozu
- E) Ülseratif kolit atağı

Doğru Cevap: Akut anal fissür

A) Akut anal fissür: Akut anal fissür kabızlık sonrası posterior orta hatta lineer yırtık, keskin dışkılama ağrısı ve parlak kırmızı kanla en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır." ve "Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Perianal apse: Perianal apsede fluktuasyon, şişlik, zonklayıcı ağrı ve ateş beklenebilir; bu olguda lineer fissür görünümü vardır. Bu olguda "Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır." ve "Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Akut anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Rektum kanseri: Rektum kanseri kilo kaybı, dışkılama alışkanlığında değişiklik veya kitleyle düşünülebilir; akut sert dışkılama sonrası lineer yırtık daha açıklayıcıdır. Bu olguda "Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır." ve "Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Akut anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.

D) İnternal hemoroid trombozu: İnternal hemoroidler genellikle ağrısız parlak kırmızı kanama yapar; bu hastada şiddetli keskin ağrı ve fissür hattı görülmektedir. Bu olguda "Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır." ve "Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Akut anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ülseratif kolit atağı: Ülseratif kolit atağında kanlı ishal ve karın ağrısı beklenir; lokal posterior anal yırtık bulgusu bu tanıyı desteklemez. Bu olguda "Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır." ve "Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Akut anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Dışkılama sonrası anal ağrı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır." ve "Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir." birlikte okunduğunda Akut anal fissür seçeneği öne çıkar; "Posterior orta hatta yüzeyel lineer yırtık izlenmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kabızlık ve sert dışkılama sonrası dışkılama sırasında cam kesiği tarzında ağrı, tuvalet kâğıdında parlak kırmızı kan ve posterior orta hatta lineer yırtık akut anal fissür için tipiktir. Perianal apse veya maligniteyi düşündürecek fluktuasyon, sistemik belirti ya da kilo kaybı verilmemiştir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır.", "Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir." ve "Posterior orta hatta yüzeyel lineer yırtık izlenmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut anal fissür en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakınmalar sert dışkılama ve kabızlık sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmiştir.

Kanıt 3: Posterior orta hatta yüzeyel lineer yırtık izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Anal fissürde tipik yakınma dışkılama sırasında keskin ağrı ve az miktarda parlak kırmızı kandır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 121: v177-new-121-dogum-sonrasi-ates-ve-uterin-hassasiyet

Başlık: Doğum sonrası ateş ve uterin hassasiyet

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Postpartum endometritte klinik bulgularla uygun antibiyotik tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, kötü kokulu vajinal akıntı ve alt karın ağrısı nedeniyle değerlendiriliyor. Üç gün önce uzamış membran rüptürü sonrası acil sezaryen doğum yaptığı öğreniliyor. Son 24 saatte titreme, halsizlik ve alt karında giderek artan ağrı tarifliyor. Emzirme sırasında meme ağrısı veya kızamıklık belirtmiyor.

Demografi: 30 yaşında kadın hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 108/68 mmHg | Nabız: 116/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.9°C | Şok indeksi: 1,07 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta halsiz görünmektedir.
- Uterus fundusu palpasyonla hassastır ve loşi kötü kokuludur.
- Meme muayenesinde lokal eritem veya hassasiyet yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Postpartum enfeksiyöz süreci destekler. | Sonuç yorumu: Postpartum enfeksiyöz süreci destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Postpartum enfeksiyöz süreci destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 17800 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Postpartum enfeksiyöz süreci destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz klindamisin ve gentamisin
B) Oral antipiretik-analjezik tedaviyle ayaktan izlem
C) Tek doz flukonazol
D) Metilergonovin ile uterotonik tedavi
E) Acil histerektomi

Doğru Cevap: İntravenöz klindamisin ve gentamisin

A) İntravenöz klindamisin ve gentamisin: İntravenöz klindamisin ve gentamisin postpartum endometritte aerob ve anaerob polimikrobiyal florayı kapsayan uygun başlangıç tedavisidir. Vakadaki "Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır." ve "Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Oral antipiretik-analjezik tedaviyle ayaktan izlem: Vakadaki Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır ve Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir. Bu olguda "Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır." ve "Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz klindamisin ve gentamisin seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Tek doz flukonazol: Flukonazol kandida vajinit gibi mantar enfeksiyonlarında kullanılır; uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşiyle giden postpartum endometriti tedavi etmez. Bu olguda "Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır." ve "Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz klindamisin ve gentamisin seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Metilergonovin ile uterotonik tedavi: Metilergonovin uterin atoni kanamasında kullanılabilir; burada temel sorun enfeksiyondur ve antibiyotik gerekir. Bu olguda "Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır." ve "Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz klindamisin ve gentamisin seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Acil histerektomi: Acil histerektomi kontrol edilemeyen ağır septik komplikasyonlarda nadiren düşünülür; başlangıç tedavisi değildir. Bu olguda "Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır." ve "Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz klindamisin ve gentamisin seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Doğum sonrası ateş ve uterin hassasiyet olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır." ve "Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir." birlikte okunduğunda İntravenöz klindamisin ve gentamisin seçeneği öne çıkar; "Lökositöz postpartum enfeksiyöz tabloyu desteklemektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sezaryen, uzamış membran rüptürü, postpartum ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi postpartum endometriti düşündürür. Tedavide polimikrobiyal aerob-anaerob florayı kapsayan intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik gerekir; klasik başlangıç rejimi klindamisin ve gentamisin. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır.", "Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir." ve "Lökositöz postpartum enfeksiyöz tabloyu desteklemektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz klindamisin ve gentamisin en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta uzamış membran rüptürü sonrası sezaryen doğum yapmıştır.

Kanıt 2: Postpartum üçüncü günde ateş, uterin hassasiyet ve kötü kokulu loşi gelişmiştir.

Kanıt 3: Lökositöz postpartum enfeksiyöz tabloyu desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Postpartum endometritte sezaryen ve uzamış membran rüptürü önemli risk faktörleridir; tedavi intravenöz geniş spektrumlu antibiyotiktir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 122: v177-new-122-dogumda-omuz-takilmesi

Başlık: Doğumda omuz takılması

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Omuz distosisinde ilk manevrayı klinik bağlamda seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Vajinal doğum sırasında fetal baş çıktıktan sonra omuzların ilerlememesi nedeniyle acil obstetrik müdahale gerekiyor. Gestasyonel diyabet öyküsü vardır ve ultrasonografide fetüsün iri olduğu belirtilmiştir. Doğum eylemi vajinal olarak ilerlemiş, baş doğduktan sonra geri çekilme görünümü izlenmiştir.

Demografi: 32 yaşında gebe hasta | Setting: Doğumhane

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fetal baş doğmuştur ancak omuzlar doğmamaktadır.
- Başın perineye doğru geri çekildiği kaplumbağa bulgusu izlenir.
- Anne hemodinamik olarak stabildir.
- Fetal kalp atımı monitörize edilmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu durumda uygulanması gereken ilk obstetrik manevra aşağıdakilerden hangisidir?

- A) McRoberts manevrası ve suprapubik bası
B) Fundal bası uygulanması
C) Acil internal podalik versiyon
D) Doğumu durdurup elektif sezaryen planlanması
E) Fetal başa traksiyonun artırılması

Doğru Cevap: McRoberts manevrası ve suprapubik bası

- A) McRoberts manevrası ve suprapubik bası: McRoberts manevrası ve suprapubik bası omuz distosisinde güvenli ve önerilen ilk müdahaledir. Vakadaki "Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır." ve "Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Fundal bası uygulanması: Fundal bası anterior omzu daha da sıkıştırabilir ve uterin rüptür ile fetal yaralanma riskini artırdığı için uygun değildir. Bu olguda "Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır." ve "Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Acil internal podalik versiyon: Internal podalik versiyon seçilmiş makat veya ikinci ikiz durumlarında düşünülür; omuz distosisinde ilk yaklaşım değildir. Bu olguda "Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır." ve "Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Doğumu durdurup elektif sezaryen planlanması: Baş doğduktan sonra elektif sezaryen planlanması pratik ve uygun bir ilk çözüm değildir; acil vajinal manevralar uygulanmalıdır. Bu olguda "Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır." ve "Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Fetal başa traksiyonun artırılması: Fetal başa traksiyonun artırılması brakial plexus hasarı riskini artırır ve omuz distosisinin uygun yönetimi değildir. Bu olguda "Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır." ve "Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Doğumda omuz takılması olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır." ve "Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir." birlikte okunduğunda McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneği öne çıkar; "Kaplumbağa bulgusu omuz distosisini desteklemektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Fetal başın doğumundan sonra omuzların ilerlememesi ve kaplumbağa bulgusu omuz distosisini gösterir. İlk yaklaşım annenin kalçalarının hiperfleksiyona getirilmesiyle sakrum-promontoryum açısını değiştiren McRoberts manevrası ve anterior omzu simfizis altından kurtarmaya yönelik suprapubik basıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır.", "Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir." ve "Kaplumbağa bulgusu omuz distosisini desteklemektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle McRoberts manevrası ve suprapubik bası en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü omuz distosisi riskini artırır.

Kanıt 2: Fetal baş doğduktan sonra omuzlar ilerlememiştir.

Kanıt 3: Kaplumbağa bulgusu omuz distosisini desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Omuz distosisinde ilk manevra McRoberts ve suprapubik basıdır; fundal bası yapılmaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 123: v177-new-123-antikoagulan-sonrasi-uyluk-gucsuzlugu

Başlık: Antikoagulan sonrası uyluk güçsüzlüğü

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Retroperitoneal hematomda femoral sinir hasarını motor ve duyu bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sol kasık ağrısı ve bacağına düzleştirmede güçlük nedeniyle başvuruyor. Atriyal fibrilasyon nedeniyle antikoagulan kullandığı ve son günlerde INR değerinin yüksek seyrettiği öğreniliyor. Travma öyküsü yoktur. Sol kasıkta ani ağrı sonrası yürüme güçlüğü başlamıştır.

Demografi: 69 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/66 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,98 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Sol kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu belirgin zayıftır.
- Patella refleksi azalmıştır.
- Uyluk ön yüzü ve bacağın medial yüzünde duyu azalması vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Abdominopelvik bilgisayarlı tomografi

Etiket: Abdominopelvik bilgisayarlı tomografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol iliopsoas kasi içinde retroperitoneal hematoma izlendi. | Klinik anlam: Femoral sinir kompresyonu açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Femoral sinir kompresyonu açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Abdominopelvik bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Sol iliopsoas kasi içinde retroperitoneal hematoma izlendi. | Yorum: Femoral sinir kompresyonu açısından anlamlıdır. | Satırlar: Abdominopelvik bilgisayarlı tomografi - Sol iliopsoas kasi içinde retroperitoneal hematoma izlendi. // Femoral sinir kompresyonu açısından anlamlıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-072 | Başlık: Abdominopelvik bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Sol iliopsoas kasi içinde retroperitoneal hematoma izlendi. | Klinik anlam: Femoral sinir kompresyonu açısından anlamlıdır. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/072_072-sol-iliopsoas-retroperitoneal-hematoma-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/072_072-sol-iliopsoas-retroperitoneal-hematoma-bt.webp | Alt text: Abdominopelvik bilgisayarlı tomografi - Sol iliopsoas kasi içinde retroperitoneal hematoma izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada bası altında kalması en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus obturatorius
- B) Nervus femoralis
- C) Nervus ischiadicus
- D) Nervus gluteus superior
- E) Nervus pudendus

Doğru Cevap: Nervus femoralis

A) Nervus obturatorius: Nervus obturatorius uyluk adduktorlarını ve medial uyluk duyunu etkiler; diz ekstansiyonu ve patella refleksi kaybını açıklamaz. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır.

B) Nervus femoralis: Nervus femoralis iliopsoas hematoma ile baskıya uğrayabilir ve kalça fleksiyonu, diz ekstansiyonu ile patella refleksi bulgularını açıklar. Vakadaki "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Nervus ischiadicus: Nervus ischiadicus arka uyluk ve bacak-ayak motor fonksiyonlarıyla ilişkilidir; anterior uyluk ve patella refleksi paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır.

D) Nervus gluteus superior: Nervus gluteus superior kalça abduktörlerini innerve eder ve Trendelenburg bulgusu yapar; diz ekstansiyonu kaybını açıklamaz. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır.

E) Nervus pudendus: Nervus pudendus perine duyu ve dış sfinkterlerle ilişkilidir; uyluk ön yüzü motor-duyu bulgularını açıklamaz. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır. Bu olguda "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ipuçları tanısallaşır.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antikoagulan sonrası uyluk güçsüzlüğü olgusunda klinik karar tanısallaşır. "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir." ve "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." birlikte okunduğunda Nervus femoralis seçeneği öne çıkar; "Patella refleksi ile uyluk ön yüzü ve medial bacak duyu azalmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İliopsoas hematoma femoral siniri retroperitoneal bölgede sıkıştırabilir. Femoral sinir iliopsoas ve quadriceps fonksiyonlarıyla ilişkilidir; kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflığı, patella refleksinde azalma ve uyluk ön-medial bacak duyu azalma bu sinir hasarını destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir.", "Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır." ve "Patella refleksi ile uyluk ön yüzü ve medial bacak duyu azalmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus femoralis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Antikoagulan kullanımı sonrası iliopsoas hematoma gelişmiştir.

Kanıt 2: Kalça fleksiyonu ve diz ekstansiyonu zayıflamıştır.

Kanıt 3: Patella refleksi ile uyluk ön yüzü ve medial bacak duyu azalmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Femoral sinir hasarında quadriceps güçsüzlüğü, patella refleksi azalması ve anterior uyluk-medial bacak duyu kaybı beklenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 124: v177-new-124-parotis-ameliyati-sonrasi-yuz-asimetrisi

Başlık: Parotis ameliyatı sonrası yüz asimetrisi

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Parotis cerrahisinde fasiyal sinir hasarını mimik kası bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ameliyat sonrası yüzün sağ tarafında hareket kaybı ve ağız köşesinde düşme nedeniyle başvuruyor. Bir hafta önce sağ parotis bezinden benign kitle eksizyonu yapıldığı öğreniliyor. Ameliyat öncesi yüz hareketlerinde sorun yoktur. İştme kaybı veya dil hareket bozukluğu tariflemiyor.

Demografi: 56 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ alın kırıştırma zayıf, sağ göz kapama yetersiz ve sağ ağız köşesi aşağı düşüktür.
- Dil orta hatta çıkarılmaktadır.
- Yumuşak damak hareketleri simetrik.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma olasılığı en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus trigeminus
- B) Nervus facialis
- C) Nervus glossopharyngeus
- D) Nervus hypoglossus
- E) Nervus vagus

Doğru Cevap: Nervus facialis

- A) Nervus trigeminus: Nervus trigeminus yüz duyusu ve çiğneme kaslarıyla ilişkilidir; mimik kaslarında yaygın motor kaybı yapmaz. Bu olguda “Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Nervus facialis: Nervus facialis parotis bezi içinde dallanır ve mimik kaslarını innerve ettiği için bu ameliyat sonrası yüz asimetrisini açıklar. Vakadaki “Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- C) Nervus glossopharyngeus: Nervus glossopharyngeus yutma ve arka dil duyusuyla ilişkilidir; alın-göz-ağız mimik kaybını açıklamaz. Bu olguda “Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nervus hypoglossus: Vakadaki Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır ve Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır. Bu olguda “Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus vagus: Nervus vagus yumuşak damak, farinks ve larinks fonksiyonlarıyla ilişkilidir; mimik kası paralizisinin temel siniri değildir. Bu olguda “Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Parotis ameliyatı sonrası yüz asimetrisi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.” birlikte okunduğunda Nervus facialis seçeneği öne çıkar; “Dil hareketi ve yumuşak damak hareketleri korunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Parotis bezi içinde dallanan fasiyal sinir mimik kaslarının motor innervasyonunu sağlar ve parotis cerrahisinde risk altındadır. Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketlerinin aynı tarafta zayıflaması periferik nervus facialis hasarını düşündürür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.”, “Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.” ve “Dil hareketi ve yumuşak damak hareketleri korunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus facialis en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Yüz hareket kaybı parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.

Kanıt 2: Alın kırıştırma, göz kapama ve ağız köşesi hareketleri aynı tarafta zayıflamıştır.

Kanıt 3: Dil hareketi ve yumuşak damak hareketleri korunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Parotis cerrahisinde risk altındaki temel sinir nervus facialis olup mimik kaslarını innerve eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 125: v177-new-125-cocukta-purpura-ve-karin-agrisi

Başlık: Çocukta purpura ve karın ağrısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Henoch-Schönlein purpurasında klinik triadı tanı ile ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, bacaklarda döküntü, karın ağrısı ve eklem ağrısı nedeniyle acile getiriliyor. Bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği öğreniliyor. Son iki gündür diz ve ayak bileklerinde ağrı, aralıklı kramp tarzı karın ağrısı ve bacaklarda döküntü gelişmiştir. Ateşi yüksek değildir.

Demografi: 7 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/66 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,98 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Alt ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde ve kalça çevresinde basmakla solmayan palpabl purpurik döküntüler vardır.
- Diz ve ayak bileklerinde hafif şişlik ve hassasiyet izlenir.
- Batın yumuşaktır ancak periumbilikal hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Trombositopenik purpura olasılığını azaltır. | Sonuç yorumu: Trombositopenik purpura olasılığını azaltır. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Trombositopenik purpura olasılığını azaltır. | Satırlar: Trombosit sayısı / 310000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Trombositopenik purpura olasılığını azaltır.

Tetkik 2: İdrar analizi

Etiket: İdrar analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Mikroskopik hematüri saptandı. | Klinik anlam: Renal tutulum açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Renal tutulum açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: İdrar analizi | Sonuç özeti: Mikroskopik hematüri saptandı. | Yorum: Renal tutulum açısından uyarıcıdır. | Satırlar: İdrar analizi / Mikroskopik hematüri saptandı. // Renal tutulum açısından uyarıcıdır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İmmün trombositopenik purpura
B) IgA vaskülit
C) Kawasaki hastalığı
D) Meningokoksemi
E) Akut romatizmal ateş

Doğru Cevap: IgA vaskülit

- A) İmmün trombositopenik purpura: İmmün trombositopenik purpura trombosit sayısı düşük beklenir; bu hastada trombosit sayısı normaldir ve karın-eklem-renal bulgular vardır. Bu olguda "Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir." ve "Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) IgA vaskülit: IgA vaskülit normal trombosit sayısı ile birlikte palpabl purpura, karın ağrısı, artralji ve hematüri paternini en iyi açıklar. Vakadaki "Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir." ve "Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- C) Kawasaki hastalığı: Kawasaki hastalığında uzun süren ateş, konjonktivit, mukozal değişiklikler ve ekstremitelerde bulguları beklenir; bu olguda palpabl purpura ve hematüri ön plandadır. Bu olguda "Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir." ve "Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Meningokoksemi: Meningokoksemi yüksek ateş, toksik görünüm ve hızla ilerleyen purpura ile seyreder; bu hasta hemodinamik olarak stabildir ve vaskülit triad belirgindir. Bu olguda "Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir." ve "Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Akut romatizmal ateş: Akut romatizmal ateşte gezici poliartrit, kardit ve streptokok sonrası bulgular beklenir; palpabl purpura ve hematüri tipik değildir. Bu olguda "Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir." ve "Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Çocukta purpura ve karın ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir." ve "Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda IgA vaskülit seçeneği öne çıkar; "Trombosit sayısı normal iken idrarda mikroskopik hematüri saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen palpabl purpura, karın ağrısı, artrit/artralji ve mikroskopik hematüri IgA vaskülitini düşündürür. Normal trombosit sayısı purpuranın trombositopeniden değil küçük damar vaskülitinden kaynaklandığını destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir.", "Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir." ve "Trombosit sayısı normal iken idrarda mikroskopik hematüri saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle IgA vaskülit en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Döküntü alt ekstremitelerde ve kalça çevresinde palpabl purpura şeklindedir.

Kanıt 2: Karın ağrısı ve eklem yakınmaları tabloya eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Trombosit sayısı normal iken idrarda mikroskopik hematüri saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: IgA vaskülit çocukta palpabl purpura, karın ağrısı, artralji ve renal tutulumla hatırlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 126: v177-new-126-yenidoganda-agir-solunum-sikintisi

Başlık: Yenidoğanda ağır solunum sıkıntısı

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Konjenital diyafram hernisinde embriyolojik defekt ve klinik sonucu ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz nedeniyle değerlendiriliyor. Antenatal ultrasonografide toraks içinde barsak ansları görüldüğü ve polihidramniyoz olduğu öğreniliyor. Doğumdan sonra beslenme denenmeden solunum sıkıntısı başlamıştır.

Demografi: 1 saatlik erkek yenidoğan | Setting: Doğum salonu

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 148/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %82% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek belirgin takipneik ve siyanozedir.
- Göğüs sol tarafında solunum sesleri azalmış, kalp sesleri sağa doğru yer değiştirmiştir.
- Batın çökük görünümündedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Torakoabdominal grafi

Etiket: Torakoabdominal grafi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal sağa itilme izlendi. | Klinik anlam: Diyafram defekti üzerinden abdominal organların toraksa geçtiğini gösterir. | Sonuç yorumu: Diyafram defekti üzerinden abdominal organların toraksa geçtiğini gösterir. | Sonuç başlığı: Torakoabdominal grafi | Sonuç özeti: Sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal sağa itilme izlendi. | Yorum: Diyafram defekti üzerinden abdominal organların toraksa geçtiğini gösterir. | Satırlar: Torakoabdominal grafi / Sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal sağa itilme izlendi. // Diyafram defekti üzerinden abdominal organların toraksa geçtiğini gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-073 | Başlık: Torakoabdominal grafi | Modalite: xray | Bulgu: Sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal sağa itilme izlendi. | Klinik anlam: Diyafram defekti üzerinden abdominal organların toraksa geçtiğini gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/073_073-konjenital-diyafagma-hernisi-torakoabdominal-grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/073_073-konjenital-diyafagma-hernisi-torakoabdominal-grafi.webp | Alt text: Torakoabdominal grafi - Sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal sağa itilme izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablonun en olası embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru
B) Tiroglossal kanalın persiste kalması
C) Nöral krest hücrelerinin distal kolona göç edememesi
D) Duktus venozusun açık kalması
E) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu

Doğru Cevap: Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru

A) Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru: Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru posterolateral diyafram defektine yol açarak abdominal organların toraksa geçmesini açıklar. Vakadaki “Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.” ve “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Tiroglossal kanalın persiste kalması: Tiroglossal kanalın persiste kalması orta hat boyun kisti oluşturur; diyafram defekti ve toraksta barsak anslarını açıklamaz. Bu olguda “Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.” ve “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Nöral krest hücrelerinin distal kolona göç edememesi: Nöral krest hücrelerinin distal kolona göç edememesi Hirschsprung hastalığına neden olur; yenidoğan solunum sıkıntısının bu mekanizması değildir. Bu olguda “Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.” ve “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Duktus venozusun açık kalması: Duktus venozusun açık kalması fetal venöz dolaşımla ilişkilidir; posterolateral diyafram açıklığını açıklamaz. Bu olguda “Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.” ve “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu: Septum primumun aşırı rezorpsiyonu atriyal septal defekt mekanizmasıdır; torakoabdominal organ yer değiştirmesiyle ilişkili değildir. Bu olguda “Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.” ve “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda ağır solunum sıkıntısı olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.” ve “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru seçeneği öne çıkar; “Grafide sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal itilme izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda sol hemitoraksta barsak ansları, mediastinal itilme, çökük batın ve ağır solunum sıkıntısı konjenital diyafram hernisini düşündürür. En sık posterolateral diyafram defekti pleuroperitoneal membranların kapanma kusurundan kaynaklanır ve akciğer hipoplazisine yol açabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.”, “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.” ve “Grafide sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal itilme izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pleuroperitoneal membranların kapanma kusuru en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Antenatal dönemde toraks içinde barsak ansları görülmüştür.

Kanıt 2: Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz gelişmiştir.

Kanıt 3: Grafide sol hemitoraksta barsak gazları ve mediastinal itilme izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Konjenital diyafram hernisinde temel tehlike abdominal organların toraksa geçmesiyle gelişen akciğer hipoplazisidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 127: v177-new-127-ani-bacak-agrisi-ve-sogukluk

Başlık: Ani bacak ağrısı ve soğukluk

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Akut ekstremitte iskemisinde klinik bulgularla acil revaskülarizasyon gereksinimini belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ bacakta ani başlayan şiddetli ağrı, soğukluk ve uyuşma nedeniyle acile getiriliyor. Atriyal fibrilasyon öyküsü vardır ve antikoagülanını son haftalarda düzenli kullanmadığı öğreniliyor. Şikâyetlerin iki saat önce aniden başladığını belirtiyor.

Demografi: 72 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 132/78 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,89

Fizik Muayene

- Sağ bacak sol bacağa göre soluk ve soğuktur.
- Sağ ayakta motor güç azalmış, duyu belirgin azalmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: El Doppler değerlendirmesi

Etiket: El Doppler değerlendirmesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sağ ayakta arteriyel akım sinyali alınmadı. | Klinik anlam: Akut arteriyel tıkanıklığı destekler. | Sonuç yorumu: Akut arteriyel tıkanıklığı destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/074_074-akut-arteriyel-tikaniklik-doppler-degerlendirme.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/074_074-akut-arteriyel-tikaniklik-doppler-degerlendirme.webp | Yorum: Akut arteriyel tıkanıklığı destekler. | Satırlar: El Doppler değerlendirmesi / Sağ ayakta arteriyel akım sinyali alınmadı. // Akut arteriyel tıkanıklığı destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-074 | Başlık: El Doppler değerlendirmesi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sağ ayakta arteriyel akım sinyali alınmadı. | Klinik anlam: Akut arteriyel tıkanıklığı destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/074_074-akut-arteriyel-tikaniklik-doppler-degerlendirme.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/074_074-akut-arteriyel-tikaniklik-doppler-degerlendirme.webp | Alt text: El Doppler değerlendirmesi - Sağ ayakta arteriyel akım sinyali alınmadı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi
B) Ayaktan oral analjezik ve poliklinik kontrolü
C) Varis çorabı verilmesi
D) Elektif venöz Doppler randevusu planlanması
E) Antibiyotik başlanması

Doğru Cevap: Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi

A) Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi: Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon, motor-duyu kaybı olan akut ekstremitte iskemisinde ekstremitteyi kurtarmaya yönelik doğru yaklaşımdır. Vakadaki "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır." ve "Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Ayaktan oral analjezik ve poliklinik kontrolü: Ayaktan analjezik ve kontrol, nabız kaybı ve nörolojik defisiti olan hastada geri dönüşsüz iskemiyi geciktirir. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır." ve "Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Varis çorabı verilmesi: Vakadaki Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır ve Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır." ve "Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Elektif venöz Doppler randevusu planlanması: Elektif venöz Doppler bu arteriyel acil durumu değerlendirmek ve tedavi etmek için yeterli değildir. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır." ve "Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Antibiyotik başlanması: Vakadaki Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır ve Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır. Bu olguda "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır." ve "Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani bacak ağrısı ve soğukluk olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır." ve "Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır." birlikte okunduğunda Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi seçeneği öne çıkar; "Motor güç ve duyu azalması ekstremitenin tehdit altında olduğunu gösterir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Atriyal fibrilasyonu olan hastada ani başlayan ekstremitte ağrısı, solukluk, soğukluk, nabız kaybı, duyu ve motor etkilenme akut ekstremitte iskemisini düşündürür. Motor-duyu defisit varlığı tehdit altındaki ekstremitteyi gösterir; gecikmeden sistemik heparinizasyon ve acil revaskülarizasyon planlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır.", "Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır." ve "Motor güç ve duyu azalması ekstremitenin tehdit altında olduğunu gösterir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil sistemik heparinizasyon ve revaskülarizasyon için damar cerrahisi girişimi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı emboli riskini artırır.

Kanıt 2: Sağ bacakta ani ağrı, solukluk, soğukluk ve nabız kaybı vardır.

Kanıt 3: Motor güç ve duyu azalması ekstremitenin tehdit altında olduğunu gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Akut ekstremitte iskemisinde ağrı, solukluk, soğukluk, nabızsızlık, parestezi ve paralizi acil revaskülarizasyon gerektirir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 128: v177-new-128-analjezik-asiri-alimi

Başlık: Analjezik aşırı alımı

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Parasetamol toksisitesinde N-asetilsistein kullanımını mekanizmasıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, çok sayıda ağrı kesici tablet aldıktan birkaç saat sonra bulantı ve karın rahatsızlığı nedeniyle acile getiriliyor. Yakınları hastanın yaklaşık 6 saat önce yüksek doz parasetamol aldığını belirtiyor. Hasta bulantı ve sağ üst kadranda hafif rahatsızlık tarifliyor. Kronik karaciğer hastalığı öyküsü yoktur.

Demografi: 23 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 116/72 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,79

Fizik Muayene

- Hasta uyanık ve koopere durumdadır.
- Sağ üst kadranda hafif hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum parasetamol düzeyi

Etiket: Serum parasetamol düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksikite riski sınırının üzerinde saptandı. | Klinik anlam: Antidot tedavisi gerekliliğini destekler. | Sonuç yorumu: Antidot tedavisi gerekliliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum parasetamol düzeyi | Sonuç özeti: Toksikite riski sınırının üzerinde saptandı. | Yorum: Antidot tedavisi gerekliliğini destekler. | Satırlar: Serum parasetamol düzeyi / Toksikite riski sınırının üzerinde saptandı. // Antidot tedavisi gerekliliğini destekler.

Tetkik 2: Alanin aminotransferaz

Etiket: Alanin aminotransferaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Başlangıçta normal saptandı. | Klinik anlam: Erken dönemde karaciğer enzimleri normal olabilir. | Sonuç yorumu: Erken dönemde karaciğer enzimleri normal olabilir. | Sonuç başlığı: Alanin aminotransferaz | Sonuç özeti: Başlangıçta normal saptandı. | Yorum: Erken dönemde karaciğer enzimleri normal olabilir. | Satırlar: Alanin aminotransferaz / 32 U/L / <35 U/L / Erken dönemde karaciğer enzimleri normal olabilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada başlanması gereken antidot tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) N-asetilsistein
B) Atropin
C) Fomepizol
D) Deferoksamin
E) Protamin sülfat

Doğru Cevap: N-asetilsistein

- A) N-asetilsistein: N-asetilsistein glutatyon depolarını destekleyerek parasetamolün toksik metaboliti NAPQI'nin detoksifikasyonunu artırır. Vakadaki "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Atropin: Atropin muskarinik belirtilerin tedavisinde kullanılır; parasetamol hepatotoksitesini önlemez. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Fomepizol: Fomepizol metanol ve etilen glikol zehirlenmelerinde alkol dehidrogenazı inhibe eder; parasetamol toksisitesinin antidotu değildir. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Deferoksamin: Deferoksamin demir zehirlenmesinde şelasyon sağlar; parasetamol metabolitini detoksifiye etmez. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Protamin sülfat: Vakadaki Hasta yüksek doz parasetamol almıştır ve Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Analjezik aşırı alımı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir." birlikte okunduğunda N-asetilsistein seçeneği öne çıkar; "Alımdan sonraki erken dönemde karaciğer enzimlerinin normal olması toksisite riskini dışlamaz." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yüksek doz parasetamol alımında toksik metabolit NAPQI glutatyon depoları tükendiğinde hepatoselüler hasar oluşturur. N-asetilsistein glutatyon prekürsörü olarak NAPQI detoksifikasyonunu artırır ve hepatotoksisiteyi önlemek için erken dönemde başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır.", "Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir." ve "Alımdan sonraki erken dönemde karaciğer enzimlerinin normal olması toksisite riskini dışlamaz." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle N-asetilsistein en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Hasta yüksek doz parasetamol almıştır.

Kanıt 2: Serum parasetamol düzeyi toksisite riski sınırının üzerindedir.

Kanıt 3: Alımdan sonraki erken dönemde karaciğer enzimlerinin normal olması toksisite riskini dışlamaz.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Parasetamol toksisitesinde N-asetilsistein glutatyonu yenileyerek NAPQI detoksifikasyonunu sağlar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 129: v177-new-129-diskilama-aliskanliginda-degisiklik

Başlık: Dışkılama alışkanlığında değişiklik

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Kolorektal adenokarsinomda sol kolon yerleşiminin klinik ve morfolojik özelliklerini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, son aylarda dışkı çapında inceltme, kabızlık ve aralıklı rektal kanama nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık dört aydır dışkılama alışkanlığının değiştiğini, dışkısının kurşun kalem gibi incelendiğini ve zaman zaman parlak-koyu kırmızı kan gördüğünü belirtiyor. İstemsiz kilo kaybı ve halsizlik de eşlik etmektedir.

Demografi: 66 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 128/76 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,69

Fizik Muayene

- Hasta hafif soluk görünmektedir.
- Batın muayenesinde belirgin defans yoktur.
- Rektal tuşede dışkıda kan bulaşı izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kronik kan kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Kronik kan kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kronik kan kaybını destekler. | Satırlar: Hemoglobin / 10.2 g/dL / 13.5-17.5 g/dL / Kronik kan kaybını destekler.

Tetkik 2: Kolonoskopi

Etiket: Kolonoskopi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sigmoid kolonda lümeni daraltan halka şeklinde ülserovejetan kitle izlendi. | Klinik anlam: Sol kolon malignitesi açısından şüphelidir. | Sonuç yorumu: Sol kolon malignitesi açısından şüphelidir. | Sonuç başlığı: Kolonoskopi | Sonuç özeti: Sigmoid kolonda lümeni daraltan halka şeklinde ülserovejetan kitle izlendi. | Yorum: Sol kolon malignitesi açısından şüphelidir. | Satırlar: Kolonoskopi / Sigmoid kolonda lümeni daraltan halka şeklinde ülserovejetan kitle izlendi. // Sol kolon malignitesi açısından şüphelidir.

Tetkik 3: Biyopsi histopatolojisi

Etiket: Biyopsi histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Atipik gland yapıları oluşturan invaziv tümör izlendi. | Klinik anlam: Adenokarsinom morfolojisini destekler. | Sonuç yorumu: Adenokarsinom morfolojisini destekler. | Sonuç başlığı: Biyopsi histopatolojisi | Sonuç özeti: Atipik gland yapıları oluşturan invaziv tümör izlendi. | Yorum: Adenokarsinom morfolojisini destekler. | Satırlar: Biyopsi histopatolojisi / Atipik gland yapıları oluşturan invaziv tümör izlendi. // Adenokarsinom morfolojisini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-075 | Başlık: Kolonoskopi | Modalite: endoscopy | Bulgu: Sigmoid kolonda lümeni daraltan halka şeklinde ülserovejetan kitle izlendi. | Klinik anlam: Sol kolon malignitesi açısından şüphelidir. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/075_075-sigmoid-ulserovejetan-kitle-kolonoskopi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/075_075-sigmoid-ulserovejetan-kitle-kolonoskopi.webp | Alt text: Kolonoskopi - Sigmoid kolonda lümeni daraltan halka şeklinde ülserovejetan kitle izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-076 | Başlık: Biyopsi histopatolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Atipik gland yapıları oluşturan invaziv tümör izlendi. | Klinik anlam: Adenokarsinom morfolojisini destekler. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/076_076-invaziv-glanduler-tumor-kolon-biyopsi-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/076_076-invaziv-glanduler-tumor-kolon-biyopsi-histopatoloji.webp | Alt text: Biyopsi histopatolojisi - Atipik gland yapıları oluşturan invaziv tümör izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kolorektal adenokarsinom
B) İrritabl bağırsak sendromu
C) Akut enfeksiyöz gastroenterit
D) Hemoroidal hastalık
E) Çölyak hastalığı

Doğru Cevap: Kolorektal adenokarsinom

A) Kolorektal adenokarsinom: Kolorektal adenokarsinom yaş, kilo kaybı, anemi, dışkı çapında inceltme ve invaziv glandüler kitle bulgularıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.” ve “Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) İrritabl bağırsak sendromu: İrritabl bağırsak sendromu kilo kaybı, anemi, rektal kanama ve kolonoskopide invaziv kitleyle açıklanamaz. Bu olguda “Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.” ve “Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Kolorektal adenokarsinom seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Akut enfeksiyöz gastroenterit: Akut enfeksiyöz gastroenterit kısa süreli ishal, ateş veya karın kramplarıyla beklenir; aylar süren lümen daraltıcı kitleye uymaz. Bu olguda “Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.” ve “Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Kolorektal adenokarsinom seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Hemoroidal hastalık: Hemoroidal hastalık rektal kanama yapabilir ancak dışkı çapında inceltme, kilo kaybı, anemi ve invaziv sigmoid kitleyi açıklamaz. Bu olguda “Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.” ve “Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Kolorektal adenokarsinom seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Çölyak hastalığı: Çölyak hastalığı malabsorpsiyon ve kronik ishale ilişkilidir; lümeni daraltan invaziv kolonik kitle bulgusu beklenmez. Bu olguda “Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.” ve “Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Kolorektal adenokarsinom seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Dışkılama alışkanlığında değişiklik olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.” ve “Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.” birlikte okunduğunda Kolorektal adenokarsinom seçeneği öne çıkar; “Kolonoskopide sigmoid kolonda lümeni daraltan kitle ve biyopside invaziv glandüler tümör gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı hastada dışkılama alışkanlığında değişiklik, dışkı çapında inceltme, rektal kanama, kilo kaybı, anemi ve sigmoid kolonda lümeni daraltan halka şeklinde kitle kolorektal adenokarsinomu düşündürür. Biyopside atipik glandüler invaziv tümör varlığı tanıyı destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.”, “Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.” ve “Kolonoskopide sigmoid kolonda lümeni daraltan kitle ve biyopside invaziv glandüler tümör gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kolorektal adenokarsinom en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Dışkılama alışkanlığında değişiklik ve dışkı çapında inceltme vardır.

Kanıt 2: Rektal kanama, kilo kaybı ve anemi kronik malign süreci destekler.

Kanıt 3: Kolonoskopide sigmoid kolonda lümeni daraltan kitle ve biyopside invaziv glandüler tümör gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Sol kolon kanserleri sıklıkla lümeni daraltan halka tarzı lezyonlarla dışkı çapında inceleme ve obstrüksiyon bulguları yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 130: v177-new-130-genc-eriskinde-atipik-pnomoni

Başlık: Genç erişkinde atipik pnömoni

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Mikoplazma pnömonisinde atipik pnömoni kliniği ve soğuk aglütinin ilişkisini kurabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, inatçı kuru öksürük, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık 10 gündür düşük dereceli ateş ve kuru öksürük tarifliyor. Yurtta kalan arkadaşlarında da benzer öksürük yakınmaları olduğunu belirtiyor. Balgam miktarı azdır ve belirgin nefes darlığı yoktur.

Demografi: 20 yaşında erkek öğrenci | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 0,75

Fizik Muayene

- Genel durumu iyidir ancak kuru öksürüğü belirgindir.
- Akciğer oskültasyon bulguları hafiftir ve klinik tabloya göre radyolojik bulguların daha belirgin olduğu düşünülmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Bilateral yamalı interstisyel infiltrasyon izlendi. | Klinik anlam: Atipik pnömoni paternini destekler. | Sonuç yorumu: Atipik pnömoni paternini destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Bilateral yamalı interstisyel infiltrasyon izlendi. | Yorum: Atipik pnömoni paternini destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Bilateral yamalı interstisyel infiltrasyon izlendi. // Atipik pnömoni paternini destekler.

Tetkik 2: Soğuk aglütinin testi

Etiket: Soğuk aglütinin testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etken için destekleyici immünolojik bulgudur. | Sonuç yorumu: Etken için destekleyici immünolojik bulgudur. | Sonuç başlığı: Soğuk aglütinin testi | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Etken için destekleyici immünolojik bulgudur. | Satırlar: Soğuk aglütinin testi / Pozitif saptandı. // Etken için destekleyici immünolojik bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-077 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Bilateral yamalı interstisyel infiltrasyon izlendi. | Klinik anlam: Atipik pnömoni paternini destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/077_077-bilateral-yamali-interstisyel-infiltrasyon-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/077_077-bilateral-yamali-interstisyel-infiltrasyon-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Bilateral yamalı interstisyel infiltrasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Streptococcus pneumoniae
B) Mycoplasma pneumoniae
C) Klebsiella pneumoniae
D) Legionella pneumophila
E) Staphylococcus aureus

Doğru Cevap: Mycoplasma pneumoniae

A) Streptococcus pneumoniae: Streptococcus pneumoniae tipik lobar pnömoni ve daha belirgin toksik klinik tabloyla beklenir; soğuk aglütinin pozitifliği bu etken için tipik değildir. Bu olguda “Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.” ve “Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mycoplasma pneumoniae seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Mycoplasma pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae genç erişkinde kuru öksürük, interstisyel infiltrasyon, yurt teması ve soğuk aglütinin pozitifliğiyle en uyumlu etkindir. Vakadaki “Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.” ve “Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

C) Klebsiella pneumoniae: Klebsiella pneumoniae genellikle yaşlı, alkol kullanımı olan veya komorbid hastalarda yoğun balgamlı nekrotizan pnömoniyle düşünülür. Bu olguda “Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.” ve “Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mycoplasma pneumoniae seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Legionella pneumophila: Legionella pneumophila su sistemi maruziyeti, gastrointestinal bulgular ve hiponatremiyle daha çok ilişkilidir; bu olguda bu ipuçları yoktur. Bu olguda “Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.” ve “Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mycoplasma pneumoniae seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus özellikle influenza sonrası nekrotizan pnömoni veya ağır hastane ilişkili enfeksiyonla öne çıkar; bu hafif atipik tabloya uymaz. Bu olguda “Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.” ve “Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mycoplasma pneumoniae seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Genç erişkinde atipik pnömoni olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.” ve “Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.” birlikte okunduğunda Mycoplasma pneumoniae seçeneği öne çıkar; “Soğuk aglütinin testi pozitif saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Genç erişkinde yurt ortamında kümelenen, kuru öksürükle seyreden hafif klinik bulgulu atipik pnömoni ve soğuk aglütinin pozitifliği Mycoplasma pneumoniae enfeksiyonunu düşündürür. Bu etken hücre duvarı içermez; bu nedenle beta-laktam antibiyotikler etkisizdir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.”, “Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.” ve “Soğuk aglütinin testi pozitif saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Mycoplasma pneumoniae tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Hasta yurt ortamında benzer yakınmaları olan kişilerle temas etmiştir.

Kanıt 2: Kuru öksürük ve hafif muayene bulgularına karşı interstisyel infiltrasyon vardır.

Kanıt 3: Soğuk aglütinin testi pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Mycoplasma pneumoniae hücre duvarı içermez ve gençlerde atipik pnömoni ile soğuk ağıltinin pozitifliği yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 131: v178-new-131-efor-dispnesi-ve-periferik-odem

Başlık: Efor dispnesi ve periferik ödem

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Kalp yetmezliğinde Frank-Starling mekanizmasının kompanzasyon ve dekompanzasyon mantığını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, son aylarda artan efor dispnesi, gece nefes darlığı ve ayak bileklerinde şişlik nedeniyle başvuruyor. Daha önce miyokard enfarktüsü geçirdiği öğreniliyor. Son haftalarda iki yastıkla yatmaya başladığını, merdiven çıkarken çabuk yorulduğunu ve kilo aldığını belirtiyor.

Demografi: 67 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %93 | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,93 (sınırdı yüksek)

Fizik Muayene

- Bilateral pretibial gode bırakan ödem vardır.
- Akciğer bazallerinde ince raller duyulur.
- Juguler venöz dolgunluk belirgindir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük saptandı. | Klinik anlam: Sistolik pompa fonksiyon bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Sistolik pompa fonksiyon bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük saptandı. | Yorum: Sistolik pompa fonksiyon bozukluğunu destekler. | Satırlar: Ekokardiyografi / 30 % / ≥55% / Sistolik pompa fonksiyon bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: B-tipi natriüretik peptid

Etiket: B-tipi natriüretik peptid | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ventrikül duvar gerilimini destekler. | Sonuç yorumu: Ventrikül duvar gerilimini destekler. | Sonuç başlığı: B-tipi natriüretik peptid | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Ventrikül duvar gerilimini destekler. | Satırlar: B-tipi natriüretik peptid / 1180 pg/mL / <100 pg/mL / Ventrikül duvar gerilimini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-078 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük saptandı. | Klinik anlam: Sistolik pompa fonksiyon bozukluğunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/078_078-dusuk-ef-ekokardiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/078_078-dusuk-ef-ekokardiyografi.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşük saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada başlangıçta atım hacmini korumaya çalışan ancak ilerleyen dönemde pulmoner konjesyona katkı sağlayan temel fizyolojik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması
- B) Azalmış venöz dönüşün atım hacmini doğrudan artırması
- C) Aortik baroreseptör aktivitesinin artmasıyla sempatik tonusun tamamen baskılanması
- D) Pulmoner kapiller basıncın düşmesiyle alveollerden sıvı emiliminin artması
- E) Ventrikül duvar geriliminin azalmasıyla natriüretik peptid salınımının artması

Doğru Cevap: Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması

A) Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması: Artmış ventrikül dolumu sarkomer uzunluğunu artırarak başlangıçta atım hacmini destekler, ancak ileri dönemde dolum basıncını yükseltip konjesyona yol açar. Vakadaki “Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.” ve “Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Azalmış venöz dönüşün atım hacmini doğrudan artırması: Azalmış venöz dönüş atım hacmini artırmaz; ventrikül dolumunu azaltarak pompa çıkışını düşürme eğilimindedir. Bu olguda “Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.” ve “Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Aortik baroreseptör aktivitesinin artmasıyla sempatik tonusun tamamen baskılanması: Kalp yetmezliğinde etkin arteriyel dolaşım azalınca baroreseptör ateşlemesi azalır ve sempatik tonus artar. Bu olguda “Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.” ve “Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pulmoner kapiller basıncın düşmesiyle alveollerden sıvı emiliminin artması: Pulmoner konjesyonda pulmoner kapiller basınç düşmez, yükselir ve alveoler sıvı birikimine katkı sağlar. Bu olguda “Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.” ve “Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ventrikül duvar geriliminin azalmasıyla natriüretik peptid salınımının artması: Natriüretik peptid salınımı ventrikül duvar gerilimi arttığında yükselir; duvar gerilimi azalmasıyla azalır. Bu olguda “Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.” ve “Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Efor dispnesi ve periferik ödem olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.” ve “Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.” birlikte okunduğunda Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması seçeneği öne çıkar; “B-tipi natriüretik peptid yüksekliği ventrikül duvar geriliminin arttığını gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sistolik kalp yetmezliğinde ventrikül boşalması bozulunca end-diastolik hacim artar. Frank-Starling mekanizması sarkomer uzunluğunu artırarak başlangıçta kasılma gücünü ve atım hacmini destekler; ancak dolum basıncı aşırı arttığında pulmoner venöz basınç yükselir ve konjesyon gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.”, “Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.” ve “B-tipi natriüretik peptid yüksekliği ventrikül duvar geriliminin arttığını gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Artmış ventrikül dolumunun sarkomer uzunluğunu artırarak kasılma gücünü geçici artırması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu düşüktür.

Kanıt 2: Ortopne, bazal raller ve juguler venöz dolgunluk konjesyonu destekler.

Kanıt 3: B-tipi natriüretik peptid yüksekliği ventrikül duvar geriliminin arttığını gösterir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Frank-Starling mekanizması erken dönemde kompensatuvardır; aşırı dolum basıncı geliştiğinde pulmoner konjesyona katkı sağlar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 132: v178-new-132-yenidoganda-agir-hiperammonemi

Başlık: Yenidoğanda ağır hiperammonemi

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Üre döngüsünde karbamoil fosfat sentetaz I eksikliğini orotik asit düzeyiyle ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, emmede azalma, letarji ve solunum düzensizliği nedeniyle yatırılıyor. Doğumdan sonraki ilk gün iyi olduğu, protein içeren beslenme arttıkça kusma ve uykuya eğilimin belirginleştiği öğreniliyor. Ailede açıklanamayan yenidoğan kaybı öyküsü vardır.

Demografi: 4 günlük kız yenidoğan | Setting: Yenidoğan yoğun bakım

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 160/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,29 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve hipotoniktir.
- Belirgin hepatosplenomegali yoktur.
- Solunumu düzensizdir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma amonyak

Etiket: Plazma amonyak | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Çok yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır üre döngüsü bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Ağır üre döngüsü bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma amonyak | Sonuç özeti: Çok yüksek saptandı. | Yorum: Ağır üre döngüsü bozukluğunu destekler. | Satırlar: Plazma amonyak / 920 µmol/L / <80 µmol/L / Ağır üre döngüsü bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: İdrar orotik asit

Etiket: İdrar orotik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Ornitin transkarbamilaz eksikliğinden ayrımda önemlidir. | Sonuç yorumu: Ornitin transkarbamilaz eksikliğinden ayrımda önemlidir. | Sonuç başlığı: İdrar orotik asit | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Ornitin transkarbamilaz eksikliğinden ayrımda önemlidir. | Satırlar: İdrar orotik asit / Normal saptandı. // Ornitin transkarbamilaz eksikliğinden ayrımda önemlidir.

Tetkik 3: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Primer hipoglisemik metabolik hastalıkları geri plana iter. | Sonuç yorumu: Primer hipoglisemik metabolik hastalıkları geri plana iter. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Primer hipoglisemik metabolik hastalıkları geri plana iter. | Satırlar: Kan glukozu / 82 mg/dL / 70-100 mg/dL / Primer hipoglisemik metabolik hastalıkları geri plana iter.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası biyokimyasal defekt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği
- B) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
- C) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği
- D) Glukoz-6-fosfataz eksikliği
- E) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği

Doğru Cevap: Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği

A) Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği: Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği ağır hiperammonemi ve normal orotik asit paternini en iyi açıklar. Vakadaki "Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir." ve "Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Ornitin transkarbamilaz eksikliği: Ornitin transkarbamilaz eksikliğinde karbamoil fosfat pirimidin sentezine kayar ve orotik asit yükselir. Bu olguda "Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir." ve "Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir." ipuçları tanısal karar açısından Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği sütle beslenme sonrası hepatik sarılık ve indirgen madde pozitifliğiyle beklenir. Bu olguda "Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir." ve "Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir." ipuçları tanısal karar açısından Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği açlık hipoglisemisi, laktik asidoz ve hepatomegaliyle seyreder; burada glukoz normaldir. Bu olguda "Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir." ve "Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir." ipuçları tanısal karar açısından Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği dalı zincirli amino asit birikimi ve tatlı idrar kokusuyla ilişkilidir. Bu olguda "Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir." ve "Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir." ipuçları tanısal karar açısından Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda ağır hiperammonemi olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir." ve "Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir." birlikte okunduğunda Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği seçeneği öne çıkar; "İdrar orotik asit düzeyi normal saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğan döneminde protein alımı sonrası ağır hiperammonemi üre döngüsü defektini düşündürür. Orotik asidin normal olması karbamoil fosfatın pirimidin sentezine aşırı yönelmediğini gösterir ve karbamoil fosfat sentetaz I eksikliğini ornitin transkarbamilaz eksikliğinden ayırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir.", "Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir." ve "İdrar orotik asit düzeyi normal saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Semptomlar protein içeren beslenme arttıkça belirginleşmiştir.

Kanıt 2: Plazma amonyak düzeyi çok yüksektir.

Kanıt 3: İdrar orotik asit düzeyi normal saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Ağır hiperammonemide orotik asit yüksekse ornitin transkarbamilaz eksikliği, normal ise karbamoil fosfat sentetaz I eksikliği düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 133: v178-new-133-lipit-dusurucu-tedavi-sonrasi-kas-agrisi

Başlık: Lipit düşürücü tedavi sonrası kas ağrısı

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Statin ilişkili miyopati riskini ilaç etkileşimi ve mekanizmayla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yaygın kas ağrısı ve güçsüzlük nedeniyle başvuruyor. Hiperkolesterolemi nedeniyle yüksek doz simvastatin kullandığı, son hafta makrolid antibiyotik başlandığı öğreniliyor. Son günlerde merdiven çıkarken belirgin kas ağrısı ve koyu renkli idrar fark etmiştir.

Demografi: 62 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 126/78 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,73

Fizik Muayene

- Hasta halsiz görünmektedir.
- Proksimal kaslarda hassasiyet vardır.
- Ateş yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kreatin kinaz

Etiket: Kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kas yıkımını destekler. | Sonuç yorumu: Kas yıkımını destekler. | Sonuç başlığı: Kreatin kinaz | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Kas yıkımını destekler. | Satırlar: Kreatin kinaz / 9200 U/L / 30-200 U/L / Kas yıkımını destekler.

Tetkik 2: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Rabdomiyolize bağlı böbrek etkilenimini düşündürür. | Sonuç yorumu: Rabdomiyolize bağlı böbrek etkilenimini düşündürür. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Rabdomiyolize bağlı böbrek etkilenimini düşündürür. | Satırlar: Serum kreatinin / 1.9 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Rabdomiyolize bağlı böbrek etkilenimini düşündürür.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki tablonun en olası farmakolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması
B) Beta-2 reseptör blokajına bağlı bronkokonstriksiyon gelişmesi
C) Asetilkolinesteraz inhibisyonuyla kolinerjik kriz oluşması
D) Dopamin D2 reseptör blokajıyla akut distoni gelişmesi
E) Vitamin K epoksit redüktaz inhibisyonuyla pıhtılaşma faktörlerinin azalması

Doğru Cevap: HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması

A) HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması: HMG-CoA redüktaz inhibitörü olan simvastatinin metabolizmasının baskılanması ilaç düzeyini artırarak miyotoksiste ve rabdomiyolize yol açabilir. Vakadaki “Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.” ve “Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Beta-2 reseptör blokajına bağlı bronkokonstriksiyon gelişmesi: Beta-2 reseptör blokajı bronkokonstriksiyonla ilişkilidir; bu hastadaki kas yıkımı ve kreatin kinaz yüksekliğini açıklamaz. Bu olguda “Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.” ve “Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Asetilkolinesteraz inhibisyonuyla kolinerjik kriz oluşması: Asetilkolinesteraz inhibisyonu kolinerjik bulgular oluşturur; bu olguda salivasyon, bronkore veya miyozis verilmemiştir. Bu olguda “Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.” ve “Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Dopamin D2 reseptör blokajıyla akut distoni gelişmesi: Dopamin D2 reseptör blokajı akut distoniye neden olabilir; rabdomiyoliz ve statin-makrolid etkileşiminin temel mekanizması değildir. Bu olguda “Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.” ve “Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Vitamin K epoksit redüktaz inhibisyonuyla pıhtılaşma faktörlerinin azalması: Vitamin K epoksit redüktaz inhibisyonu warfarinin etkisidir; kas yıkımı ve kreatin kinaz yüksekliğiyle ilişkili değildir. Bu olguda “Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.” ve “Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Lipit düşürücü tedavi sonrası kas ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.” ve “Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.” birlikte okunduğunda HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması seçeneği öne çıkar; “Kreatin kinaz ve kreatinin yüksekliği rabdomiyoliz ve böbrek etkilenimini destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yüksek doz simvastatin kullanan hastada makrolid sonrası kas ağrısı, kreatin kinaz yüksekliği, koyu idrar ve kreatinin artışı statin ilişkili rabdomiyolizi düşündürür. Simvastatin CYP3A4 ile metabolize edilir; bazı makrolidler bu metabolizmayı baskılayarak statin düzeyini ve miyotoksiste riskini artırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.”, “Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.” ve “Kreatin kinaz ve kreatinin yüksekliği rabdomiyoliz ve böbrek etkilenimini destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle HMG-CoA redüktaz inhibisyonu yapan ilacın metabolizmasının baskılanmasıyla toksisite riskinin artması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta yüksek doz simvastatin kullanmaktadır.

Kanıt 2: Makrolid antibiyotik başlanmasından sonra yaygın kas ağrısı gelişmiştir.

Kanıt 3: Kreatin kinaz ve kreatinin yüksekliği rabdomiyoliz ve böbrek etkilenimini destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Statinlerde makrolid gibi CYP3A4 inhibitörleri miyopati ve rabdomiyoliz riskini artırabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 134: v178-new-134-postmenopozal-vajinal-kanama

Başlık: Postmenopozal vajinal kanama

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Endometrium kansinomuunda karşılanmamış östrojen maruziyeti ve histolojik tanıyı ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, menopozdan yıllar sonra başlayan vajinal kanama nedeniyle başvuruyor. Menopoz 9 yıl önce girdiği, son bir ayda aralıklı vajinal kanamalarının olduğu öğreniliyor. Obezite, hipertansiyon ve tip 2 diyabet öyküsü vardır. Doğum yapmamıştır.

Demografi: 61 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 146/88 mmHg | Nabız: 86/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,59

Fizik Muayene

- Hasta obez görünümündedir.
- Spekulum muayenesinde servikte belirgin kitle izlenmez.
- Bimanuel muayenede uterus hafif büyük hissedilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Klinik anlam: Endometrial patoloji açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Endometrial patoloji açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Yorum: Endometrial patoloji açısından anlamlıdır. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / 14 mm / Postmenopozal dönemde genellikle <4 mm / Endometrial patoloji açısından anlamlıdır.

Tetkik 2: Endometrial biyopsi

Etiket: Endometrial biyopsi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Atipik glandüler proliferasyon ve invazyon gösteren endometrioid tip adenokarsinom izlendi. | Klinik anlam: Tanıyı destekleyen histolojik bulgudur. | Sonuç başlığı: Endometrial biyopsi | Sonuç özeti: Atipik glandüler proliferasyon ve invazyon gösteren endometrioid tip adenokarsinom izlendi. | Yorum: Tanıyı destekleyen histolojik bulgudur. | Satırlar: Endometrial biyopsi / Atipik glandüler proliferasyon ve invazyon gösteren endometrioid tip adenokarsinom izlendi. // Tanıyı destekleyen histolojik bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-079 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Klinik anlam: Endometrial patoloji açısından anlamlıdır. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/079_079-endometrium-kalinligi-artisi-transvajinal-usg.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/079_079-endometrium-kalinligi-artisi-transvajinal-usg.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-080 | Başlık: Endometrial biyopsi | Modalite: microscopy | Bulgu: Atipik glandüler proliferasyon ve invazyon gösteren endometrioid tip adenokarsinom izlendi. | Klinik anlam: Tanıyı destekleyen histolojik bulgudur. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/080_080-endometrioid-adenokarsinom-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/080_080-endometrioid-adenokarsinom-histopatoloji.webp | Alt text: Endometrial biyopsi - Atipik glandüler proliferasyon ve invazyon gösteren endometrioid tip adenokarsinom izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endometrium adenokarsinomu
- B) Servikal skuamöz hücreli karsinom
- C) Over disgerminomu
- D) Vulvar lichen sclerosus
- E) Gestasyonel trofoblastik hastalık

Doğru Cevap: Endometrium adenokarsinomu

A) Endometrium adenokarsinomu: Endometrium adenokarsinomu postmenopozal kanama, karşılanmamış östrojen riskleri ve invaziv endometrioid biyopsi bulgusuyla en uyumlu anamneştir. Vakadaki “Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.” ve “Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Servikal skuamöz hücreli karsinom: Servikal skuamöz hücreli karsinom servikal lezyon ve HPV ilişkisiyle düşünülür; bu olguda endometrial kalınlaşma ve endometrioid biyopsi vardır. Bu olguda “Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.” ve “Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometrium adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Over disgerminomu: Over disgerminomu genellikle genç hastalarda over kitlesiyle seyredir; postmenopozal endometrial kanama ve biyopsi bulgusunu açıklamaz. Bu olguda “Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.” ve “Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometrium adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Vulvar lichen sclerosus: Vulvar lichen sclerosus vulvar kaşıntı ve deri değişiklikleriyle ilişkilidir; endometrial invaziv glandüler tümör değildir. Bu olguda “Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.” ve “Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometrium adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Gestasyonel trofoblastik hastalık: Gestasyonel trofoblastik hastalık gebelik ilişkili beta-hCG yüksekliğiyle beklenir; bu hasta postmenopozal dönemdedir. Bu olguda “Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.” ve “Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometrium adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Postmenopozal vajinal kanama olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.” ve “Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.” birlikte okunduğunda Endometrium adenokarsinomu seçeneği öne çıkar; “Biyopside invaziv endometrioid tip adenokarsinom gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Postmenopozal vajinal kanama, obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrium adenokarsinomu açısından risk oluşturur. Artmış endometrium kalınlığı ve biyopside invaziv endometrioid adenokarsinom tanıyı destekler; patogeneizde karşılanmamış östrojen etkisi önemlidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.”, “Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.” ve “Biyopside invaziv endometrioid tip adenokarsinom gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Endometrium adenokarsinomu en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Kanama postmenopozal dönemde ortaya çıkmıştır.

Kanıt 2: Obezite, hipertansiyon, diyabet ve nulliparite endometrial kanser riskini artırır.

Kanıt 3: Biyopside invaziv endometrioid tip adenokarsinom gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Postmenopozal kanama aksi kanıtlanana kadar endometrium kanseri açısından değerlendirilmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 135: v178-new-135-yasli-hastada-menenjit

Başlık: Yaşlı hastada menenjit

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Listeria menenjitinde risk grubu ve mikrobiyolojik özellikleri tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle acile getiriliyor. Son iki gündür ateş ve iştahsızlık olduğu, bugün konuşmasının yavaşladığı öğreniliyor. Diyabet öyküsü vardır. Son hafta pastörize edilmemiş süt ürünü tükettiği belirtiliyor.

Demografi: 76 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/66 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.9°C | Şok indeksi: 1,04 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta konfüzidir.
- Ense sertliği vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyin omurilik sıvısı analizi

Etiket: Beyin omurilik sıvısı analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nötrofil ağırlıklı pleositoz ve protein yüksekliği saptandı. | Klinik anlam: Bakteriyel menenjit lehinedir. | Sonuç yorumu: Bakteriyel menenjit lehinedir. | Sonuç başlığı: Beyin omurilik sıvısı analizi | Sonuç özeti: Nötrofil ağırlıklı pleositoz ve protein yüksekliği saptandı. | Yorum: Bakteriyel menenjit lehinedir. | Satırlar: Beyin omurilik sıvısı analizi / Nötrofil ağırlıklı pleositoz ve protein yüksekliği saptandı. // Bakteriyel menenjit lehinedir.

Tetkik 2: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama

Etiket: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Kısa gram-pozitif basil yapıları görüldü. | Klinik anlam: Etken ayrımında önemlidir. | Sonuç yorumu: Etken ayrımında önemlidir. | Sonuç başlığı: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Sonuç özeti: Kısa gram-pozitif basil yapıları görüldü. | Yorum: Etken ayrımında önemlidir. | Satırlar: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama / Kısa gram-pozitif basil yapıları görüldü. // Etken ayrımında önemlidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-081 | Başlık: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Modalite: microscopy | Bulgu: Kısa gram-pozitif basil yapıları görüldü. | Klinik anlam: Etken ayrımında önemlidir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/081_081-listeria-kisa-gram-pozitif-basil-bos-gram-boyama.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/081_081-listeria-kisa-gram-pozitif-basil-bos-gram-boyama.webp | Alt text: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama - Kısa gram-pozitif basil yapıları görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Neisseria meningitidis
- B) Streptococcus pneumoniae
- C) Listeria monocytogenes
- D) Haemophilus influenzae tip b
- E) Cryptococcus neoformans

Doğru Cevap: Listeria monocytogenes

A) Neisseria meningitidis: Neisseria meningitidis gram-negatif diplokoktur ve purpurik sepsisle ilişkilidir; gram-pozitif basil bulgusuyla uymaz. Bu olguda “Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.” ve “Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.” ipuçları tanısallık karar açısından Listeria monocytogenes seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Streptococcus pneumoniae: Streptococcus pneumoniae gram-pozitif diplokok yapısındadır; kısa gram-pozitif basil ve süt ürünü maruziyeti Listeria lehinedir. Bu olguda “Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.” ve “Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.” ipuçları tanısallık karar açısından Listeria monocytogenes seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Listeria monocytogenes: Listeria monocytogenes yaşlı risk grubunda pastörize edilmemiş gıda sonrası gram-pozitif basil menenjitleriyle en uyumlu etkindir. Vakadaki “Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.” ve “Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

D) Haemophilus influenzae tip b: Haemophilus influenzae tip b küçük gram-negatif kokobasıldır; bu Vakadaki gram-pozitif basil morfolojisini açıklamaz. Bu olguda “Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.” ve “Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.” ipuçları tanısallık karar açısından Listeria monocytogenes seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Cryptococcus neoformans: Cryptococcus neoformans kapsüllü maya formundadır ve özellikle hücrel immün yetmezlikte menenjit yapar; gram-pozitif basil değildir. Bu olguda “Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.” ve “Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.” ipuçları tanısallık karar açısından Listeria monocytogenes seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yaşlı hastada menenjit olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. “Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.” ve “Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.” birlikte okunduğunda Listeria monocytogenes seçeneği öne çıkar; “Gram boyamada kısa gram-pozitif basil yapıları görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı ve diyabetik hastada pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi sonrası menenjit gelişmesi ve beyin omurilik sıvısında kısa gram-pozitif basil görülmesi Listeria monocytogenes için tipiktir. Bu etken yaşlılar, gebeler, yenidoğanlar ve immün sistemi baskılanmış kişilerde menenjit yapabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.”, “Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.” ve “Gram boyamada kısa gram-pozitif basil yapıları görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Listeria monocytogenes en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta yaşlı ve diyabetik olduğu için risk grubundadır.

Kanıt 2: Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi öyküsü vardır.

Kanıt 3: Gram boyamada kısa gram-pozitif basil yapıları görülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtta ayrılır.

Exam Pearl: Yaşlı, gebe, yenidoğan veya immünsüpre hastada gram-pozitif basil menenjitisi Listeria düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 136: v178-new-136-skrotumda-ele-gelmeyen-testis

Başlık: Skrotumda ele gelmeyen testis

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: İnmemiş testiste gubernakulum ve testis inişi mekanizmasını klinik bulguyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, sağ skrotumda testisin ele gelmemesi nedeniyle getiriliyor. Doğumdan beri sağ skrotumun boş görüldüğü, takiplerde testisin skrotuma inmediği öğreniliyor. Prematürite öyküsü vardır. İdrar yapma sorunu tariflenmiyor.

Demografi: 8 aylık erkek bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ hemiskrotum daha küçüktür ve testis skrotumda palpe edilemez.
- Sağ inguinal kanalda küçük oval yapı palpe edilir.
- Sol testis skrotumdadır.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İnguinoskrotal ultrasonografi

Etiket: İnguinoskrotal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ testis inguinal kanal düzeyinde izlendi. | Klinik anlam: Kriptorşidizm lokalizasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Kriptorşidizm lokalizasyonunu destekler. | Sonuç başlığı: İnguinoskrotal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sağ testis inguinal kanal düzeyinde izlendi. | Yorum: Kriptorşidizm lokalizasyonunu destekler. | Satırlar: İnguinoskrotal ultrasonografi / Sağ testis inguinal kanal düzeyinde izlendi. / / Kriptorşidizm lokalizasyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-082 | Başlık: İnguinoskrotal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sağ testis inguinal kanal düzeyinde izlendi. | Klinik anlam: Kriptorşidizm lokalizasyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/082_082-inguinal-kanalda-testis-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/082_082-inguinal-kanalda-testis-ultrasonografi.webp | Alt text: İnguinoskrotal ultrasonografi - Sağ testis inguinal kanal düzeyinde izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu durumun gelişiminde bozulması en olası süreç aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gubernakulum aracılı testis inişi
B) Müller kanalının uterusu dönüşmesi
C) Nöral tüpün rostral nöropor kapanması
D) Omfalomezenterik kanal obliterasyonu
E) Duktus arteriozusun fonksiyonel kapanması

Doğru Cevap: Gubernakulum aracılı testis inişi

A) Gubernakulum aracılı testis inişi: Gubernakulum aracılı testis inişinin bozulması inguinal kanalda kalan inmemiş testis tablosunu açıklar. Vakadaki “Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.” ve “Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Müller kanalının uterusu dönüşmesi: Müller kanalının uterusu dönüşmesi kadın iç genital gelişimiyle ilişkilidir; erkek bebekte testis inişini açıklamaz. Bu olguda “Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.” ve “Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Gubernakulum aracılı testis inişi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nöral tüpün rostral nöropor kapanması: Rostral nöropor kapanma kusuru anensefali gibi kranial nöral tüp defektlerine yol açar; kriptorşidizm mekanizması değildir. Bu olguda “Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.” ve “Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Gubernakulum aracılı testis inişi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Omfalomezenterik kanal obliterasyonu: Omfalomezenterik kanal obliterasyon kusuru Meckel divertikülü gibi gastrointestinal kalıntılar oluşturur; testis inişiyle ilişkili değildir. Bu olguda “Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.” ve “Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Gubernakulum aracılı testis inişi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Duktus arteriozusun fonksiyonel kapanması: Duktus arteriozusun kapanması neonatal dolaşım değişikliğiyle ilgilidir; skrotuma testis inişini açıklamaz. Bu olguda “Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.” ve “Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Gubernakulum aracılı testis inişi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Skrotumda ele gelmeyen testis olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.” ve “Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.” birlikte okunduğunda Gubernakulum aracılı testis inişi seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide sağ testis inguinal kanalda gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Skrotumda testisin ele gelmemesi ve inguinal kanalda testis izlenmesi kriptorşidizmi düşündürür. Testisin karın içinden skrotuma inişinde gubernakulum rehberlik eder; bu süreç bozulduğunda testis inişi tamamlanamayabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.”, “Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.” ve “Ultrasonografide sağ testis inguinal kanalda gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Gubernakulum aracılı testis inişi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Sağ skrotum doğumdan beri boş görünmektedir.

Kanıt 2: Muayenede sağ testis skrotumda değil inguinal kanal düzeyinde palpe edilmektedir.

Kanıt 3: Ultrasonografide sağ testis inguinal kanalda gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtta ayrılır.

BRANŞ: general-surgery

VAKA 137: v178-new-137-epigastrik-agri-ve-kusma

Başlık: Epigastrik ağrı ve kusma

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Akut pankreatitte erken şiddet göstergeleri ve başlangıç yönetimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sırtta yayılan şiddetli epigastrik ağrı ve tekrarlayan kusma nedeniyle acile başvuruyor. Ağrının bol alkollü yemek sonrası başladığını, öne eğilmekle kısmen azaldığını belirtiyor. Daha önce benzer ancak hafif atakları olmuştur. Safra taşı öyküsü bilinmemektedir.

Demografi: 48 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 96/60 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,27 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta ağırlı ve dehidrate görünümündedir.
- Epigastriumda belirgin hassasiyet vardır, yaygın peritonit bulgusu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetik 1: Serum lipaz

Etiket: Serum lipaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut pankreatit lehinedir. | Sonuç yorumu: Akut pankreatit lehinedir. | Sonuç başlığı: Serum lipaz | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Akut pankreatit lehinedir. | Satırlar: Serum lipaz / 1450 U/L / <60 U/L / Akut pankreatit lehinedir.

Tetik 2: Kan üre azotu

Etiket: Kan üre azotu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hipovolemi ve şiddet riski açısından önemlidir. | Sonuç yorumu: Hipovolemi ve şiddet riski açısından önemlidir. | Sonuç başlığı: Kan üre azotu | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hipovolemi ve şiddet riski açısından önemlidir. | Satırlar: Kan üre azotu / 34 mg/dL / 7-20 mg/dL / Hipovolemi ve şiddet riski açısından önemlidir.

Tetik 3: Hematokrit

Etiket: Hematokrit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hemokonsantrasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Hemokonsantrasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Hematokrit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hemokonsantrasyonu destekler. | Satırlar: Hematokrit / 49 % / 40-50% / Hemokonsantrasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada başlangıçta en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem
B) Acil pankreatektomi
C) Rutin profilaktik antibiyotik başlanması
D) Ayaktan oral analjezik tedavi ve yakın kontrol
E) Hemen yüksek yağlı oral beslenme başlanması

Doğru Cevap: Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem

A) Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem: Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın izlem akut pankreatitte hipovolemi ve ağrıyı hedefleyen uygun başlangıç tedavisidir. Vakadaki "Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır." ve "Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Acil pankreatektomi: Acil pankreatektomi akut pankreatitin rutin başlangıç tedavisi değildir ve yalnızca seçilmiş komplikasyonlarda cerrahi düşünülür. Bu olguda "Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır." ve "Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tedavi önceliği açısından Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Rutin profilaktik antibiyotik başlanması: Profilaktik antibiyotik steril akut pankreatitte rutin olarak önerilmez; enfekte nekroz veya kolanjit gibi özel durumlar gerekir. Bu olguda "Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır." ve "Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tedavi önceliği açısından Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Ayaktan oral analjezik tedavi ve yakın kontrol: Vakadaki Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır ve Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda "Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır." ve "Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tedavi önceliği açısından Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hemen yüksek yağlı oral beslenme başlanması: Hemen yüksek yağlı beslenme semptomları artırabilir; başlangıçta hidrasyon, ağrı kontrolü ve klinik durumuna göre beslenme planı yapılır. Bu olguda "Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır." ve "Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tedavi önceliği açısından Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Epigastrik ağrı ve kusma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır." ve "Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir." birlikte okunduğunda Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem seçeneği öne çıkar; "Hipotansiyon, taşikardi, yüksek kan üre azotu ve hemokonsantrasyon hipovolemiyi destekler." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sırtta yayılan epigastrik ağrı, kusma ve lipaz yüksekliği akut pankreatiti gösterir. Hipotansiyon, taşikardi, yüksek kan üre azotu ve hemokonsantrasyon hipovolemi ve şiddet riskini düşündürür; başlangıç tedavisi agresif intravenöz sıvı replasmanı, etkili analjezi ve yakın izlemdir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır.", "Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir." ve "Hipotansiyon, taşikardi, yüksek kan üre azotu ve hemokonsantrasyon hipovolemiyi destekler." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Agresif intravenöz sıvı replasmanı, analjezi ve yakın klinik izlem en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ağrı epigastrik başlayıp sırtta yayılmakta ve öne eğilmekle azalmaktadır.

Kanıt 2: Serum lipaz düzeyi belirgin yüksektir.

Kanıt 3: Hipotansiyon, taşikardi, yüksek kan üre azotu ve hemokonsantrasyon hipovolemiyi destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

BRANŞ: pediatrics

VAKA 138: v178-new-138-kanli-ishal-sonrasi-oliguri

Başlık: Kanlı ishal sonrası oligüri

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: HUS tablosunda destek tedavi ve antibiyotik kaçınma mantığını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, kanlı ishal sonrası gelişen halsizlik, idrar azalması ve solukluk nedeniyle acile getiriliyor. Beş gün önce az pişmiş hamburger yedikten sonra karın ağrısı ve kanlı ishal başladığı öğreniliyor. İshal son iki günde azalmış ancak idrar miktarı belirgin düşmüş ve halsizlik artmıştır.

Demografi: 4 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 128/82 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve halsizdir.
- Hafif periorbital ödem vardır.
- Ciltte yaygın peteşi yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemogloblin

Etiket: Hemogloblin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Hemolitik anemiyi destekler. | Sonuç yorumu: Hemolitik anemiyi destekler. | Sonuç başlığı: Hemogloblin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Hemolitik anemiyi destekler. | Satırlar: Hemogloblin / 7.8 g/dL / 11.5-14.5 g/dL / Hemolitik anemiyi destekler.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik süreçle uyumludur. | Sonuç yorumu: Mikroanjyopatik süreçle uyumludur. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Mikroanjyopatik süreçle uyumludur. | Satırlar: Trombosit sayısı / 62000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Mikroanjyopatik süreçle uyumludur.

Tetkik 3: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik hemolizi gösterir. | Sonuç yorumu: Mikroanjyopatik hemolizi gösterir. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Şistositler izlendi. | Yorum: Mikroanjyopatik hemolizi gösterir. | Satırlar: Periferik yayma / Şistositler izlendi. / / Mikroanjyopatik hemolizi gösterir.

Tetkik 4: Kreatinin

Etiket: Kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut böbrek hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Akut böbrek hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut böbrek hasarını destekler. | Satırlar: Kreatinin / 2.1 mg/dL / 0.3-0.7 mg/dL / Akut böbrek hasarını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-083 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjyopatik hemolizi gösterir. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/083_083-hus-sistositler-periferik-yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/083_083-hus-sistositler-periferik-yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Şistositler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun temel tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi
- B) Rutin geniş spektrumlu antibiyotik ve antitrombotik ilaç başlanması
- C) Yüksek doz kortikosteroid ile ayakta izlem
- D) Acil splenektomi
- E) Oral demir tedavisi

Doğru Cevap: Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi

- A) Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi: Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyaliz, HUS'ta organ desteğini sağlayan temel tedavi yaklaşımıdır. Vakadaki "Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır." ve "Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Rutin geniş spektrumlu antibiyotik ve antitrombotik ilaç başlanması: Rutin antibiyotik ve antitrombotik ilaçlar Shiga toksin ilişkili tablo toksin salınımı veya komplikasyon riskini artırabileceği için uygun temel yaklaşım değildir. Bu olguda "Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır." ve "Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Yüksek doz kortikosteroid ile ayakta izlem: Kortikosteroid ve ayakta izlem akut böbrek hasarı ve trombositopenisi olan bu hasta için güvenli değildir. Bu olguda "Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır." ve "Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Acil splenektomi: Vakadaki Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır ve Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler. Bu olguda "Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır." ve "Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Oral demir tedavisi: Vakadaki Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır ve Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler. Bu olguda "Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır." ve "Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kanlı ishal sonrası oligüri olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır." ve "Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler." birlikte okunduğunda Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi seçeneği öne çıkar; "Oligüri ve kreatinin yüksekliği akut böbrek hasarını gösterir." ise ayrıca kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kanlı ishal sonrası gelişen mikroanjyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek hasarı tipik hemolitik üremik sendrom tablosudur. Shiga toksin ilişkili olgularda temel tedavi destek tedavisidir; sıvı-elektrolit dengesi, hipertansiyon kontrolü, transfüzyon ihtiyacı ve gerekirse diyaliz değerlendirilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır.", "Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjyopatik hemolizi destekler." ve "Oligüri ve kreatinin yüksekliği akut böbrek hasarını gösterir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Sıvı-elektrolit dengesi, kan basıncı kontrolü ve gerekirse diyalizi içeren destek tedavisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanlı ishal az pişmiş et tüketiminden sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Anemi, trombositopeni ve şistositler mikroanjiyopatik hemolizi destekler.

Kanıt 3: Oligüri ve kreatinin yüksekliği akut böbrek hasarını gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Tipik HUS'ta tedavi destekleyicidir; antibiyotik ve antitoksin ilaçlar Shiga toksin salınımı açısından sakıncalı olabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 139: v178-new-139-erken-gebelik-haftasında-su-gelisi

Başlık: Erken gebelik haftasında su gelişi

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Preterm erken membran rüptüründe gebelik haftasına göre konservatif yönetimi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, vajenden ani sıvı gelişi nedeniyle acile başvuruyor. Yaklaşık 3 saat önce berrak sıvı gelişi başladığını, düzenli kasılma hissetmediğini ve vajinal kanaması olmadığını belirtiyor. Ateş, kötü kokulu akıntı veya karın ağrısı tariflemiyor. Fetal hareketleri hissetmektedir.

Demografi: 29 yaşında gebe hasta | Setting: Doğum acil ünitesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 0,79

Fizik Muayene

- Hasta genel durumu iyi ve afebrildir.
- Uterin hassasiyet yoktur.
- Spekulum muayenesinde serviksten berrak sıvı gelişi izlenir.
- Dijital vajinal muayene yapılmamıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fetal kalp hızı izlemi

Etiket: Fetal kalp hızı izlemi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Reaktif patern izlendi. | Klinik anlam: Akut fetal distres bulgusu yoktur. | Sonuç yorumu: Akut fetal distres bulgusu yoktur. | Sonuç başlığı: Fetal kalp hızı izlemi | Sonuç özeti: Reaktif patern izlendi. | Yorum: Akut fetal distres bulgusu yoktur. | Satırlar: Fetal kalp hızı izlemi / 145 /dk / 110-160 /dk / Akut fetal distres bulgusu yoktur.

Tetkik 2: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin lökositoz saptanmadı. | Klinik anlam: Klinik enfeksiyon bulgusunu desteklemez. | Sonuç yorumu: Klinik enfeksiyon bulgusunu desteklemez. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Belirgin lökositoz saptanmadı. | Yorum: Klinik enfeksiyon bulgusunu desteklemez. | Satırlar: Tam kan sayımı / 9800 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Klinik enfeksiyon bulgusunu desteklemez.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem
- B) Dijital vajinal muayene ile servikal açıklığın tekrarlı değerlendirilmesi
- C) Acil doğum indüksiyonu ve rutin histerektomi
- D) Antibiyotiksiz ayaktan yakın izlem planlamak
- E) Yüksek doz metotreksat tedavisi

Doğru Cevap: Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem

A) Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem: Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın izlem 31 haftalık stabil preterm erken membran rüptüründe uygun yönetimdir. Vakadaki "Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir." ve "Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Dijital vajinal muayene ile servikal açıklığın tekrarlı değerlendirilmesi: Tekrarlı dijital vajinal muayene enfeksiyon riskini arttırabileceği için membran rüptürü şüphesinde kaçınılması gereken bir yaklaşımdır. Bu olguda "Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir." ve "Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Acil doğum indüksiyonu ve rutin histerektomi: Acil doğum indüksiyonu enfeksiyon, fetal distres veya ileri gebelik haftası gibi belirli durumlarda düşünülür; rutin histerektominin yeri yoktur. Bu olguda "Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir." ve "Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Antibiyotiksiz ayaktan yakın izlem planlamak: Vakadaki Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir ve Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir. Bu olguda "Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir." ve "Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Yüksek doz metotreksat tedavisi: Metotreksat ektopik gebelik gibi seçilmiş durumlarda kullanılır; preterm membran rüptürü yönetiminde yeri yoktur. Bu olguda "Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir." ve "Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken gebelik haftasında su gelişi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir." ve "Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir." birlikte okunduğunda Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem seçeneği öne çıkar; "Ateş, uterin hassasiyet, belirgin lökositoz veya fetal distres bulgusu yoktur." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gebeliğin 31. haftasında membran rüptürü, enfeksiyon, fetal distres veya aktif doğum bulgusu olmadan gelişmişse preterm erken membran rüptürü olarak yönetilir. Uygun yaklaşım fetal akciğer matürasyonu için antenatal kortikosteroid, latensi süresini uzatmaya yönelik antibiyotik ve yakın maternal-fetal izlemidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir.", "Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir." ve "Ateş, uterin hassasiyet, belirgin lökositoz veya fetal distres bulgusu yoktur." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kortikosteroid, latensi antibiyotigi ve yakın maternal-fetal izlem en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Gebelik haftası 31 hafta olup preterm dönemdedir.

Kanıt 2: Spekulum muayenesinde berrak sıvı gelişi görülmüş ve düzenli kontraksiyon tariflenmemiştir.

Kanıt 3: Ateş, uterin hassasiyet, belirgin lökositoz veya fetal distres bulgusu yoktur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Preterm erken membran rüptüründe enfeksiyon veya fetal distres yoksa gebelik haftasına göre konservatif yönetim, kortikosteroid ve latensi antibiyotiği düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 140: v178-new-140-immunsuprese-hastada-subakut-menenjit

Başlık: İmmünsüprese hastada subakut menenjit

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Cryptococcus neoformans menenjitini kapsül ve risk faktörüyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, iki haftadır süren baş ağrısı, ateş ve giderek artan bilinç bulanıklığı nedeniyle yatırılıyor. HIV enfeksiyonu olduğu ve antiretroviral tedavisini düzensiz kullandığı öğreniliyor. Son haftalarda kilo kaybı ve gece terlemesi tarifliyor. Kuş dışkıyla temas ettiği bir ortamda çalıştığını belirtmektedir.

Demografi: 42 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 98/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.1°C | Şok indeksi: 0,88

Fizik Muayene

- Hasta uykuya eğilimlidir.
- Ense sertliği hafiftir.
- Fokal motor defisit saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: CD4 T lenfosit sayısı

Etiket: CD4 T lenfosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Hücresel immün yetmezliği destekler. | Sonuç yorumu: Hücresel immün yetmezliği destekler. | Sonuç başlığı: CD4 T lenfosit sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Hücresel immün yetmezliği destekler. | Satırlar: CD4 T lenfosit sayısı / 48 /mm³ / >500 /mm³ / Hücresel immün yetmezliği destekler.

Tetkik 2: Beyin omurilik sıvısı mürekkep preparatı

Etiket: Beyin omurilik sıvısı mürekkep preparatı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Kalın kapsüllü maya hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Kapsüllü mantar enfeksiyonu lehinedir. | Sonuç yorumu: Kapsüllü mantar enfeksiyonu lehinedir. | Sonuç başlığı: Beyin omurilik sıvısı mürekkep preparatı | Sonuç özeti: Kalın kapsüllü maya hücreleri izlendi. | Yorum: Kapsüllü mantar enfeksiyonu lehinedir. | Satırlar: Beyin omurilik sıvısı mürekkep preparatı / Kalın kapsüllü maya hücreleri izlendi. // Kapsüllü mantar enfeksiyonu lehinedir.

Tetkik 3: Beyin omurilik sıvısı kriptokok antijeni

Etiket: Beyin omurilik sıvısı kriptokok antijeni | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni destekler. | Sonuç yorumu: Etkeni destekler. | Sonuç başlığı: Beyin omurilik sıvısı kriptokok antijeni | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni destekler. | Satırlar: Beyin omurilik sıvısı kriptokok antijeni / Pozitif saptandı. // Etkeni destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cryptococcus neoformans
B) Candida albicans
C) Aspergillus fumigatus
D) Histoplasma capsulatum
E) Mucor türleri

Doğru Cevap: Cryptococcus neoformans

A) Cryptococcus neoformans: Cryptococcus neoformans ileri hücresel immün yetmezlikte kapsüllü maya formuyla subakut menenjit yapan en olası etkindir. Vakadaki "Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır." ve "Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Candida albicans: Candida albicans mukokutanöz enfeksiyon ve kandidemi yapabilir ancak mürekkep preparatında kalın kapsüllü maya ve kriptokok antijen pozitifliği beklenmez. Bu olguda "Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır." ve "Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür." ipuçları tanısız karar açısından Cryptococcus neoformans seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Aspergillus fumigatus: Aspergillus fumigatus septalı dar açılı hiflerle invaziv akciğer enfeksiyonu yapar; kapsüllü maya menenjiti paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda "Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır." ve "Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür." ipuçları tanısız karar açısından Cryptococcus neoformans seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Histoplasma capsulatum: Histoplasma capsulatum makrofaj içinde küçük maya formlarıyla sistemik enfeksiyon yapabilir; beyin omurilik sıvısında kapsüllü maya bulgusu Cryptococcus lehinedir. Bu olguda "Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır." ve "Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür." ipuçları tanısız karar açısından Cryptococcus neoformans seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Mucor türleri: Mucor türleri geniş septasız hiflerle rinocerebral enfeksiyon yapar; kapsüllü maya ve kriptokok antijen pozitifliğiyle uyumlu değildir. Bu olguda "Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır." ve "Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür." ipuçları tanısız karar açısından Cryptococcus neoformans seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: İmmünsüprese hastada subakut menenjit olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır." ve "Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür." birlikte okunduğunda Cryptococcus neoformans seçeneği öne çıkar; "Beyin omurilik sıvısında kalın kapsüllü maya hücreleri ve kriptokok antijen pozitifliği saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İleri HIV enfeksiyonu olan hastada subakut menenjit, düşük CD4 sayısı, beyin omurilik sıvısında kalın kapsüllü maya hücreleri ve kriptokok antijen pozitifliği Cryptococcus neoformans menenjitini düşündürür. Bu etken polisakkarit kapsülüyle fagositozdan kaçabilir ve kuş dışkıyla kontamine çevresel

kaynaklardan edinilebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır.”, “Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür.” ve “Beyin omurilik sıvısında kalın kapsüllü maya hücreleri ve kriptokok antijen pozitifliği saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Cryptococcus neoformans en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada ileri derecede düşük CD4 T lenfosit sayısı vardır.

Kanıt 2: Subakut baş ağrısı, ateş ve bilinç bulanıklığı meningeal enfeksiyonu düşündürür.

Kanıt 3: Beyin omurilik sıvısında kalın kapsüllü maya hücreleri ve kriptokok antijen pozitifliği saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: AIDS hastasında subakut menenjit ve mürekkep preparatında kapsüllü maya Cryptococcus neoformans için klasiktir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 141: v179-new-141-besin-sonrasi-akut-reaksiyon

Başlık: Besin sonrası akut reaksiyon

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta anafilakside ilk acil tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, fıstık içeren bir yiyecek yedikten kısa süre sonra gelişen döküntü, nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 15 dakika önce ağız çevresinde kaşıntı ve yaygın kızarıklık başladığı, ardından öksürük, hırıltı ve baş dönmesi geliştiği öğreniliyor. Daha önce besin alerjisi şüphesi olduğu ancak düzenli takip edilmediği belirtiliyor.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 78/44 mmHg | Nabız: 142/dk | Solunum: 32/dk | SpO₂: %90% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,82 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk huzursuz ve soluk görünümündedir.
- Dudaklarda hafif ödem, yaygın ürtiker plakları ve bilateral ekspiryumda hışıltı vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntramüsküler adrenalın uygulanması
B) Oral antihistaminik verilmesi
C) Nebülize salbutamol ve antihistaminik sonrası sistemik bulguların seyrine göre adrenalın kararını vermek
D) İntravenöz kortikosteroid yanıtına göre tedavi planlamak
E) Alerji testi yapıldıktan sonra tedavinin ertelenmesi

Doğru Cevap: İntramüsküler adrenalın uygulanması

A) İntramüsküler adrenalın uygulanması: İntramüsküler adrenalın hava yolu ödemi, bronkospazm ve vazodilatasyona bağlı hipotansiyonu hızla hedeflediği için ilk tedavidir. Vakadaki “Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Oral antihistaminik verilmesi: Oral antihistaminik kaşıntı ve ürtikeri azaltabilir ancak hipotansiyon ve bronkospazmı düzelterken hayat kurtarıcı ilk tedavi değildir. Bu olguda “Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nebülize salbutamol ve antihistaminik sonrası sistemik bulguların seyrine göre adrenalın kararını vermek: Vakadaki Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır ve Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler. Bu olguda “Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) İntravenöz kortikosteroid yanıtına göre tedavi planlamak: Vakadaki Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır ve Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler. Bu olguda “Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Alerji testi yapıldıktan sonra tedavinin ertelenmesi: Alerji testi tanısal planlama için daha sonra düşünülebilir; akut sistemik reaksiyonda tedavi geciktirilmemelidir. Bu olguda “Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından intramüsküler adrenalın uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Besin sonrası akut reaksiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.” ve “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.” birlikte okunduğunda İntramüsküler adrenalın uygulanması seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon, hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşme yaşamı tehdit eden tutulumu gösterir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Besin alımından dakikalar sonra gelişen ürtiker, dudak ödemi, bronkospazm ve hipotansiyon çocukta anafilaksiyi gösterir. Anafilakside ilk ve hayat kurtarıcı tedavi intramüsküler adrenalindir; antihistaminik, bronkodilatör, sıvı ve kortikosteroidler destek tedavileridir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.”, “Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.” ve “Hipotansiyon, hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşme yaşamı tehdit eden tutulumu gösterir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntramüsküler adrenalın uygulanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Yakınmalar fıstık içeren besin alımından kısa süre sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Yaygın ürtiker ve dudak ödemi sistemik alerjik reaksiyonu destekler.

Kanıt 3: Hipotansiyon, hışıltı ve oksijen satürasyonunda düşme yaşamı tehdit eden tutulumu gösterir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve

geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Çocukta anafilaksi şüphesinde ilk tedavi gecikmeden intramüsküler adrenalindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 142: v179-new-142-uzayan-nobet

Başlık: Uzayan nöbet

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Pediatrik status epilepticusta ilk ilaç tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, evde başlayan ve acil servise geldiğinde devam eden jeneralize kasılma nedeniyle getiriliyor. Ailesi nöbetin yaklaşık 8 dakikadır sürdüğünü, çocuğun ateşli olduğunu ve nöbet sırasında bilincinin kapalı kaldığını belirtiyor. Daha önce epilepsi tanısı yoktur.

Demografi: 3 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 150/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 39.1°C | Şok indeksi: 1,50 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocukta jeneralize tonik-klonik aktivite devam etmektedir.
- Hava yolu sekresyonları artmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Hipoglisemiye bağlı nöbet olasılığı geri plandadır. | Sonuç yorumu: Hipoglisemiye bağlı nöbet olasılığı geri plandadır. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Hipoglisemiye bağlı nöbet olasılığı geri plandadır. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / 96 mg/dL / 70-140 mg/dL / Hipoglisemiye bağlı nöbet olasılığı geri plandadır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Hava yolu güvenliği ve oksijen desteği sağlanırken bu çocukta ilk uygulanması gereken antikonvülzan tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması
B) Oral antiepileptik reçetesiyle ayaktan izlem planlamak
C) Elektroensefalografi çekilene kadar ilaç verilmemesi
D) Kontrol tedavisi olarak oral valproat tedavisine başlanması
E) Ateş düşürücü verilerek nöbetin izlenmesi

Doğru Cevap: İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması

A) İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması: İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uzayan aktif nöbeti hızla durdurmak için uygun ilk antikonvülzan tedavidir. Vakadaki "Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir." ve "Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Oral antiepileptik reçetesiyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir ve jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir. Bu olguda "Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir." ve "Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Elektroensefalografi çekilene kadar ilaç verilmemesi: Elektroensefalografi tanısız değer taşıyabilir ancak devam eden nöbette tedavi verilmesini geciktirmemelidir. Bu olguda "Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir." ve "Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Kontrol tedavisi olarak oral valproat tedavisine başlanması: Vakadaki Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir ve jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir. Bu olguda "Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir." ve "Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ateş düşürücü verilerek nöbetin izlenmesi: Vakadaki Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir ve jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir. Bu olguda "Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir." ve "Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzayan nöbet olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir." ve "Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir." birlikte okunduğunda İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması seçeneği öne çıkar; "Kapiller glukoz normal olduğu için hipoglisemi hemen düzeltilecek primer neden değildir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Beş dakikadan uzun süren jeneralize nöbet status epilepticus olarak yönetilmelidir. Hava yolu, oksijen ve damar yolu değerlendirilirken ilk antikonvülzan tedavi hızlı etkili benzodiazepindir; yol durumuna göre intravenöz lorazepam/diazepam veya intranazal/bukkal midazolam kullanılabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir.", "Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir." ve "Kapiller glukoz normal olduğu için hipoglisemi hemen düzeltilecek primer neden değildir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz veya intranazal benzodiazepin uygulanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Nöbet yaklaşık 8 dakikadır devam etmektedir.

Kanıt 2: Jeneralize tonik-klonik aktivite acil serviste sürmektedir.

Kanıt 3: Kapiller glukoz normal olduğu için hipoglisemi hemen düzeltilecek primer neden değildir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Pediatrik status epilepticusta ilk ilaç benzodiazepindir; tedavi elektroensefalografi beklenerek geciktirilmez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 143: v179-new-143-hiperglisemi-ve-kusma

Başlık: Hiperglisemi ve kusma

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta diyabetik ketoasidozda ilk sıvı tedavisi ve potasyum-insülin sırasını belirleyebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, karın ağrısı, kusma, halsizlik ve hızlı soluma nedeniyle acile getiriliyor. Son haftalarda çok su içme, sık idrara çıkma ve kilo kaybı olduğu öğreniliyor. Son 24 saatte tekrarlayan kusma ve belirgin halsizlik gelişmiştir. Daha önce diyabet tanısı yoktur.

Demografi: 11 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/52 mmHg | Nabız: 138/dk | Solunum: 32/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,57 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk dehidrate ve bitkin görünümündedir.
- Derin hızlı solunumu ve meyvensi nefes kokusu vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum glukoz

Etiket: Serum glukoz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Belirgin hiperglisemi mevcuttur. | Sonuç yorumu: Belirgin hiperglisemi mevcuttur. | Sonuç başlığı: Serum glukoz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Belirgin hiperglisemi mevcuttur. | Satırlar: Serum glukoz / 560 mg/dL / 70-140 mg/dL / Belirgin hiperglisemi mevcuttur.

Tetkik 2: Venöz kan gazı

Etiket: Venöz kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Ketoasidoz şiddetini gösterir. | Sonuç yorumu: Ketoasidoz şiddetini gösterir. | Sonuç başlığı: Venöz kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Ketoasidoz şiddetini gösterir. | Satırlar: Venöz kan gazı / pH 7.12, HCO₃ 8 mmol/L / pH 7.35-7.45, HCO₃ 22-26 mmol/L / Ketoasidoz şiddetini gösterir.

Tetkik 3: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: İnsülin öncesi potasyum replasmanı gerektirebilir. | Sonuç yorumu: İnsülin öncesi potasyum replasmanı gerektirebilir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: İnsülin öncesi potasyum replasmanı gerektirebilir. | Satırlar: Serum potasyum / 3.1 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / İnsülin öncesi potasyum replasmanı gerektirebilir.

Tetkik 4: İdrar ketonu

Etiket: İdrar ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Ketotik tabloyu destekler. | Sonuç yorumu: Ketotik tabloyu destekler. | Sonuç başlığı: İdrar ketonu | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Ketotik tabloyu destekler. | Satırlar: İdrar ketonu / Pozitif saptandı. / Ketotik tabloyu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi
- B) İntravenöz insülin bolusu verilmesi
- C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanıp izlem yapılması
- D) Rutin sodyum bikarbonat bolusu verilmesi
- E) Oral sıvı desteği ve ayaktan glukoz izlemi planlamak

Doğru Cevap: İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi

- A) İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi: İzotonik sıvı replasmanı ve potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi bu hipokalemi pediatrik DKA hastasında doğru ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) İntravenöz insülin bolusu verilmesi: İnsülin bolusu çocuk DKA yönetiminde rutin değildir ve düşük potasyum varlığında aritmi riskini artırabilir. Bu olguda “Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Subkutan hızlı etkili insülin uygulanıp izlem yapılması: Vakadaki Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır ve Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir. Bu olguda “Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Rutin sodyum bikarbonat bolusu verilmesi: Sodyum bikarbonat rutin kullanılmaz; seçilmiş çok ağır asidoz durumları dışında riskleri nedeniyle ilk basamak değildir. Bu olguda “Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Oral sıvı desteği ve ayaktan glukoz izlemi planlamak: Vakadaki Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır ve Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir. Bu olguda “Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hiperglisemi ve kusma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.” birlikte okunduğunda İzotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi seçeneği öne çıkar; “Serum potasyumunun düşük olması insülin öncesi potasyum güvenliğini kritik hale getirir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hiperglisemi, keton pozitifliği, metabolik asidoz ve dehidratasyon pediatrik diyabetik ketoasidozu gösterir. İlk yaklaşım dolaşımı düzeltmek için izotonik sıvıdır; potasyum düşüğe insülin potasyumu hücre içine kaydırarak hayatı tehdit eden hipokalemiyi ağırlaştırabileceği için potasyum düzeltilmeden insülin başlanmamalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.”, “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.” ve “Serum potasyumunun düşük olması insülin öncesi potasyum güvenliğini kritik hale getirir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle izotonik sıvı replasmanı başlanması ve düşük potasyum düzeltilmeden insülinin ertelenmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocukta hiperglisemi, keton pozitifliği ve metabolik asidoz vardır.

Kanıt 2: Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dehidratasyonu gösterir.

Kanıt 3: Serum potasyumunun düşük olması insülin öncesi potasyum güvenliğini kritik hale getirir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: DKA’da ilk adım sıvıdır; potasyum düşüğe insülin başlanmadan önce potasyum replasmanı yapılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 144: v179-new-144-hisilti-ve-solunum-sikintisi

Başlık: Hışiltı ve solunum sıkıntısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Ağır astım atağında başlangıç acil tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, giderek artan nefes darlığı, öksürük ve hışiltı nedeniyle acile getiriliyor. Astım tanısı olduğu, son iki gündür viral üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının ardından kurtarıcı inhaler ihtiyacının arttığı öğreniliyor. Evde salbutamole rağmen rahatlatamamıştır.

Demografi: 8 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 138/dk | Solunum: 36/dk | SpO₂: %88% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,68 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır.
- Bilateral yaygın hışiltı vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun başlangıç acil tedavi kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid
- B) Oral antihistaminik tedavi ve ayakta izlem
- C) Uzun etkili beta-2 agonist monoterapisi
- D) Antibiyotik başlanıp bronkodilatör verilmemesi
- E) Sedatif verilerek solunum eforunun azaltılması

Doğru Cevap: Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid

A) Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid: Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid ağır astım atağının uygun başlangıç tedavisidir. Vakadaki "Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Oral antihistaminik tedavi ve ayakta izlem: Vakadaki Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır ve Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür. Bu olguda "Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Uzun etkili beta-2 agonist monoterapisi: Uzun etkili beta-2 agonist monoterapisi akut ağır atakta uygun değildir ve kontrolsüz kullanım risklidir. Bu olguda "Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Antibiyotik başlanıp bronkodilatör verilmemesi: Antibiyotik bakteriyel enfeksiyon kanıtı yoksa rutin değildir; bronkodilatör tedavinin geciktirilmesi solunum yetmezliği riskini artırır. Bu olguda "Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Sedatif verilerek solunum eforunun azaltılması: Vakadaki Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır ve Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür. Bu olguda "Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hışiltı ve solunum sıkıntısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür." birlikte okunduğunda Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid seçeneği öne çıkar; "Evde salbutamole rağmen rahatlatma olmamıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipoksemi, yardımcı solunum kası kullanımı, konuşmada zorlanma ve ev tedavisine yanıtızlık ağır astım atağını gösterir. İlk acil tedavi oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ağır atakta ipratropium eklenmesi ve sistemik kortikosteroidden oluşur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır.", "Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür." ve "Evde salbutamole rağmen rahatlatma olmamıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oksijen, tekrarlayan inhale kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk cümle kurmakta zorlanmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır.

Kanıt 2: Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür.

Kanıt 3: Evde salbutamole rağmen rahatlatma olmamıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ağır astım atağında oksijen, kısa etkili beta-2 agonist, ipratropium ve sistemik steroid birlikte erken verilmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 145: v179-new-145-havlar-tarzda-öksürük-ve-stridor

Başlık: Havlar tarzda öksürük ve stridor

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Ağır krup atağında nebulize adrenalin ve steroid tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, gece başlayan havlar tarzda öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle acile getiriliyor. İki gündür burun akıntısı ve hafif ateş olduğu, gece aniden havlar tarzda öksürük ve gürültülü solunum geliştiği öğreniliyor. Yutma güçlüğü veya salya akması tariflenmiyor.

Demografi: 2 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 34/dk | SpO₂: %93% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk huzursuzdur.
- İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır.
- Ağızdan salya akışı yoktur, oturur pozisyonda öne eğilme ihtiyacı belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması
B) Nebülize salbutamol ve antibiyotik yanıtına göre üst hava yolu tedavisini ertelemek
C) Acil tonsillektomi
D) Oral antibiyotik başlanması
E) Zorlu dil basacağı muayenesi yapılması

Doğru Cevap: Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması

A) Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması: Dekametazon ve nebulize adrenalin istirahat stridoru olan orta-ağır krup atağında uygun acil tedavidir. Vakadaki "Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Nebülize salbutamol ve antibiyotik yanıtına göre üst hava yolu tedavisini ertelemek: Vakadaki Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır ve istirahat stridor ve suprasternal çekilme vardır. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Acil tonsillektomi: Vakadaki Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır ve istirahat stridor ve suprasternal çekilme vardır. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral antibiyotik başlanması: Vakadaki Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır ve istirahat stridor ve suprasternal çekilme vardır. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Zorlu dil basacağı muayenesi yapılması: Zorlu dil basacağı muayenesi üst hava yolu obstrüksiyonu şüphesinde ajitasyonu ve hava yolu riskini artırabilir. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Havlar tarzda öksürük ve stridor olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır." birlikte okunduğunda Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması seçeneği öne çıkar; "Salya akması ve toksik oturuş olmaması epiglottiti geri plana iter." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası havlar tarzda öksürük, inspiratuvar stridor ve çekilme viral krupı düşündürür. İstirahatte stridor ve solunum eforu orta-ağır krup bulgusudur; tedavide sistemik steroid ve hızlı ödem azaltıcı etki için nebulize adrenalin kullanılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır.", "İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır." ve "Salya akması ve toksik oturuş olmaması epiglottiti geri plana iter." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Dekametazon ve nebulize adrenalin uygulanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Havlar tarzda öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını takiben başlamıştır.

Kanıt 2: İstirahatte inspiratuvar stridor ve suprasternal çekilme vardır.

Kanıt 3: Salya akması ve toksik oturuş olmaması epiglottiti geri plana iter.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamaya yerine geçmez.

Exam Pearl: Krupta tüm derecelerde steroid verilir; istirahat stridor varsa nebulize adrenalin eklenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 146: v179-new-146-ates-ve-salya-akması

Başlık: Ateş ve salya akması

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Epiglottitte hava yolu güvenliğini önceliğini klinik bulgularla seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş, yutma güçlüğü ve solunum sıkıntısı nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi şikâyetlerin birkaç saat içinde hızla kötüleştiğini, çocuğun su içemediğini ve salyasını yutamadığını belirtiyor. Aşılarının eksik olduğu öğreniliyor.

Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 152/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 39.5°C | Şok indeksi: 1,52 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk toksik görünümündür, tripod pozisyonunda oturmakta ve salya akıtmaktadır.
- Konuşması boğuk, inspiratuvar stridoru vardır.
- Ağız içi muayeneye dirençlidir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk ve en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması
B) Dil basacağı ile farenksin ayrıntılı muayene edilmesi
C) Ayaktan oral antibiyotik verilmesi
D) Nebülize salbutamol verilerek ayaktan izlem planlanması
E) Alerji testi yapılması

Doğru Cevap: Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması

A) Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması: Kontrollü ortamda hava yolunun güvenceye alınması epiglottitte ani obstrüksiyon riskini azaltan ilk ve en güvenli yaklaşımdır. Vakadaki “Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.” ve “Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Dil basacağı ile farenksin ayrıntılı muayene edilmesi: Dil basacağı ile zorlu muayene epiglottitte laringospazm ve tam hava yolu obstrüksiyonu riskini artırabilir. Bu olguda “Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.” ve “Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Ayaktan oral antibiyotik verilmesi: Vakadaki Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir ve Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır. Bu olguda “Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.” ve “Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nebülize salbutamol verilerek ayaktan izlem planlanması: Vakadaki Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir ve Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır. Bu olguda “Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.” ve “Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Alerji testi yapılması: Vakadaki Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir ve Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır. Bu olguda “Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.” ve “Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve salya akması olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.” ve “Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.” birlikte okunduğunda Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması seçeneği öne çıkar; “Boğuk ses ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” ise ayıncı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hızlı başlangıçlı yüksek ateş, toksik görünüm, tripod pozisyonu, salya akması, boğuk ses ve stridor epiglottiti düşündürür. Bu tabloda öncelik ajitasyonu artırmadan, kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınmasıdır; zorlu boğaz muayenesi akut obstrüksiyon riskini artırabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.”, “Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.” ve “Boğuk ses ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kontrollü ortamda deneyimli ekip tarafından hava yolunun güvenceye alınması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuk toksik görünümü ve yüksek ateşlidir.

Kanıt 2: Salya akması, yutma güçlüğü ve tripod pozisyonu vardır.

Kanıt 3: Boğuk ses ve inspiratuvar stridor üst hava yolu obstrüksiyonunu düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağı yerine geçmez.

Exam Pearl: Epiglottit şüphesinde boğaz zorla muayene edilmez; öncelik kontrollü hava yolu güvenliğidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 147: v179-new-147-ates-ve-dolasim-bozuklugu

Başlık: Ateş ve dolaşım bozukluğu

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta septik şokta ilk saat yönetimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş, halsizlik ve bilinçte dalgalanma nedeniyle acile getiriliyor. Son iki gündür ateşi olduğu, bugün sıvı alımının azaldığı ve uykuya eğilimin arttığı öğreniliyor. Son saatlerde idrar yapmadığı belirtiliyor.

Demografi: 5 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 74/42 mmHg | Nabız: 168/dk | Solunum: 34/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 39.6°C | Şok indeksi: 2,27 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk letarjik ve toksik görünümündedir.
- Ekstremiteler soğuk, kapiller dolum süresi 5 saniyedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Doku hipoperfüzyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Doku hipoperfüzyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Doku hipoperfüzyonunu destekler. | Satırlar: Serum laktat / 5.6 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L / Doku hipoperfüzyonunu destekler.

Tetkik 2: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Enfeksiyöz inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Enfeksiyöz inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Enfeksiyöz inflamasyonu destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 22600 /mm³ / 5000-15000 /mm³ / Enfeksiyöz inflamasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk saat içinde uygulanması gereken en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör
- B) Kan kültürü sonucu çıkana kadar antibiyotiği erteleyip yalnız sıvı yanıtını izlemek
- C) Kan kültürü sonucu çıkana kadar antibiyotiğin ertelenmesi
- D) Oral rehidratasyon ile ayaktan takip
- E) Rutin diüretik verilmesi

Doğru Cevap: Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör

A) Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör: Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken antibiyotik ve gerekirse vazopressör pediatrik septik şokta uygun ilk saat yaklaşımıdır. Vakadaki “Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Kan kültürü sonucu çıkana kadar antibiyotiği erteleyip yalnız sıvı yanıtını izlemek: Vakadaki Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir ve Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir. Bu olguda “Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Kan kültürü sonucu çıkana kadar antibiyotiğin ertelenmesi: Kan kültürü alınması değerlidir ancak sonuç beklenerek antibiyotiğin geciktirilmesi septik şokta mortaliteyi artırabilir. Bu olguda “Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral rehidratasyon ile ayaktan takip: Vakadaki Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir ve Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir. Bu olguda “Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Rutin diüretik verilmesi: Diüretik intravasküler hacim ve perfüzyon bozukluğunu kötüleştirebilir; septik şokta rutin ilk tedavi değildir. Bu olguda “Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve dolaşım bozukluğu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.” birlikte okunduğunda Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör seçeneği öne çıkar; “Laktat yüksekliği doku hipoperfüzyonunu destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationele: Ateş, letarji, hipotansiyon, taşikardi, soğuk ekstremiteler, uzamış kapiller dolum ve laktat yüksekliği pediatrik septik şoku düşündürür. İlk saat yönetiminde oksijen ve dolaşım desteği sağlanmalı, izotonik sıvı bolusları ve erken geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalı; sıvıya yanıtızsız şokta vazopressör desteği düşünülmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.”, “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.” ve “Laktat yüksekliği doku hipoperfüzyonunu destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oksijen, damar yolu, izotonik sıvı bolusları, erken geniş spektrumlu antibiyotik ve yanıt yoksa vazopressör en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk yüksek ateşli, letarjik ve toksik görünümündedir.

Kanıt 2: Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum dolaşım yetmezliğini gösterir.

Kanıt 3: Laktat yüksekliği doku hipoperfüzyonunu destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Pediatrik septik şokta ilk saat; oksijen, damar yolu, sıvı resüsitasyonu, erken antibiyotik ve gerekirse vazopressör mantığıyla yönetilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 148: v179-new-148-ani-baslayan-tek-terafli-hisilti

Başlık: Ani başlayan tek taraflı hisilti

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta yabancı cisim aspirasyonunda klinik bulgularla uygun tanısal-terapötik yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, oyun sırasında ani öksürük atağı ve sonrasında devam eden hisilti nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi çocuğun fındık yerken aniden öksürmeye başladığını, kısa süreli morardığını ve ardından sağ taraflı hisiltisinin devam ettiğini belirtiyor. Daha önce astım veya tekrarlayan hisilti öyküsü yoktur.

Demografi: 2 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 32/dk | SpO₂: %94% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,56 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk uyanık ve huzursuzdur.
- Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve ekspiryumda lokalize hisilti duyulmaktadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ akciğerde hava hapsi ve mediastende hafif sola itilme izlendi. | Klinik anlam: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Sağ akciğerde hava hapsi ve mediastende hafif sola itilme izlendi. | Yorum: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Sağ akciğerde hava hapsi ve mediastende hafif sola itilme izlendi. / / Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-084 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ akciğerde hava hapsi ve mediastende hafif sola itilme izlendi. | Klinik anlam: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/084_084-tek-terafli-hava-hapsi-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/084_084-tek-terafli-hava-hapsi-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Sağ akciğerde hava hapsi ve mediastende hafif sola itilme izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması
B) Kontrol tedavisi olarak inhale steroid başlanması
C) Oral antibiyotik ve poliklinik kontrolü
D) Alerji testi yapılması
E) Antitussif semptomatik tedaviyle ayaktan izlem planlamak

Doğru Cevap: Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması

A) Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması: Rijit bronkoskopi güçlü yabancı cisim aspirasyonu şüphesinde hem tanı koyar hem yabancı cismin çıkarılmasını sağlar. Vakadaki “Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Kontrol tedavisi olarak inhale steroid başlanması: Vakadaki Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır ve Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır. Bu olguda “Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Oral antibiyotik ve poliklinik kontrolü: Vakadaki Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır ve Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır. Bu olguda “Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Alerji testi yapılması: Vakadaki Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır ve Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır. Bu olguda “Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Antitussif semptomatik tedaviyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır ve Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır. Bu olguda “Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani başlayan tek taraflı hisilti olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.” birlikte okunduğunda Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması seçeneği öne çıkar; “Grafide sağ akciğerde hava hapsi izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kuruyemiş yerken ani öksürük ve morarma atağı, sonrasında tek taraflı azalmış solunum sesi, lokalize hisilti ve hava hapsi yabancı cisim aspirasyonunu düşündürür. Şüpheli güçlü olduğunda tanısal ve terapötik yaklaşım rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılmasıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.”, “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.” ve “Grafide sağ akciğerde hava hapsi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Rijit bronkoskopi ile yabancı cismin çıkarılması en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Şikâyetler fındık yerken ani öksürük atağıyla başlamıştır.

Kanıt 2: Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve lokalize hisilti vardır.

Kanıt 3: Grafide sağ akciğerde hava hapsi izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Çocukta ani öksürük sonrası tek taraflı hisilti ve hava hapsi yabancı cisim aspirasyonunu düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 149: v179-new-149-tablet-alimi-sonrasi-kusma-ve-metabolik-asidoz

Başlık: Tablet alımı sonrası kusma ve metabolik asidoz

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta demir zehirlenmesinde klinik evre ve şelasyon tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, evde çok sayıda demir tableti aldıktan sonra kusma ve halsizlik nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi çocuğun yaklaşık 4 saat önce anneye ait demir tabletlerinden bilinmeyen sayıda yuttuğunu fark ettiklerini belirtiyor. Ardından tekrarlayan kusma, karın ağrısı ve giderek artan halsizlik gelişmiştir.

Demografi: 3 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 152/dk | Solunum: 34/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,85 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk letarjik ve soluk görünümündedir.
- Batında yaygın hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum demir düzeyi

Etiket: Serum demir düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ciddi demir toksisitesini destekler. | Sonuç yorumu: Ciddi demir toksisitesini destekler. | Sonuç başlığı: Serum demir düzeyi | Sonuç özeti: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Yorum: Ciddi demir toksisitesini destekler. | Satırlar: Serum demir düzeyi / 620 µg/dL / 50-150 µg/dL / Ciddi demir toksisitesini destekler.

Tetkik 2: Venöz kan gazı

Etiket: Venöz kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Sistemik toksisite ve şok etkisini gösterir. | Sonuç yorumu: Sistemik toksisite ve şok etkisini gösterir. | Sonuç başlığı: Venöz kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Sistemik toksisite ve şok etkisini gösterir. | Satırlar: Venöz kan gazı / pH 7.21, HCO₃ 12 mmol/L / pH 7.35-7.45, HCO₃ 22-26 mmol/L / Sistemik toksisite ve şok etkisini gösterir.

Tetkik 3: Abdominal grafi

Etiket: Abdominal grafi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Mide bölgesinde çok sayıda radyoopak tablet görünümü izlendi. | Klinik anlam: Tablet alımını destekler. | Sonuç yorumu: Tablet alımını destekler. | Sonuç başlığı: Abdominal grafi | Sonuç özeti: Mide bölgesinde çok sayıda radyoopak tablet görünümü izlendi. | Yorum: Tablet alımını destekler. | Satırlar: Abdominal grafi / Mide bölgesinde çok sayıda radyoopak tablet görünümü izlendi. // Tablet alımını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-085 | Başlık: Abdominal grafi | Modalite: xray | Bulgu: Mide bölgesinde çok sayıda radyoopak tablet görünümü izlendi. | Klinik anlam: Tablet alımını destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/085_085-radyoopak-tabletler-abdominal-grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/085_085-radyoopak-tabletler-abdominal-grafi.webp | Alt text: Abdominal grafi - Mide bölgesinde çok sayıda radyoopak tablet görünümü izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun spesifik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Deferoksamin tedavisi
B) N-asetilsistein tedavisi
C) Nalokson tedavisi
D) Vitamin K tedavisi
E) Flumazenil tedavisi

Doğru Cevap: Deferoksamin tedavisi

- A) Deferoksamin tedavisi: Deferoksamin demiri bağlayan şelatör olarak ciddi demir zehirlenmesinde uygun spesifik tedavidir. Vakadaki “Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.” ve “Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) N-asetilsistein tedavisi: Vakadaki Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir ve Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir. Bu olguda “Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.” ve “Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nalokson tedavisi: Nalokson opioid toksisitesinde kullanılır; demir kaynaklı gastrointestinal ve metabolik toksisiteyi düzeltmez. Bu olguda “Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.” ve “Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Vitamin K tedavisi: Vitamin K warfarin etkisini geri çevirmek için kullanılır; demir zehirlenmesinde antidot değildir. Bu olguda “Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.” ve “Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Flumazenil tedavisi: Flumazenil benzodiazepin toksisitesinde reseptör antagonizması yapar; demir toksisitesini tedavi etmez. Bu olguda “Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.” ve “Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tablet alımı sonrası kusma ve metabolik asidoz olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.” ve “Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.” birlikte okunduğunda Deferoksamin tedavisi seçeneği öne çıkar; “Serum demir düzeyi toksik aralıktadır ve metabolik asidoz vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Demir tableti alımı sonrası tekrarlayan kusma, karın ağrısı, hipotansiyon, metabolik asidoz ve toksik serum demir düzeyi ciddi demir zehirlenmesini gösterir. Spesifik şelasyon tedavisi deferoksamindir; destek tedavisi ve uygun dekontaminasyon yaklaşımı eş zamanlı değerlendirilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.”, “Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.” ve “Serum demir düzeyi toksik aralıktadır ve metabolik asidoz vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Deferoksamin tedavisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuğun çok sayıda demir tableti aldığı öğrenilmiştir.

Kanıt 2: Kusma, karın ağrısı, hipotansiyon ve letarji sistemik toksisiteyi gösterir.

Kanıt 3: Serum demir düzeyi toksik aralıktadır ve metabolik asidoz vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamayı yerine geçmez.

Exam Pearl: Ciddi demir zehirlenmesinde şelatör tedavi deferoksamindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 150: v179-new-150-yenidoganda-direncli-siyanoz

Başlık: Yenidoğanda dirençli siyanoz

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Duktus bağımlı konjenital kalp hastalığında prostaglandin E1 başlanmasını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme sırasında artan morarma ve oksijen desteğine sınırlı yanıt nedeniyle değerlendiriliyor. Doğumdan sonraki ilk saatlerde stabil olduğu, ikinci günde giderek belirginleşen siyanoz ve emmede bozulma geliştiği öğreniliyor. Prenatal kardiyak değerlendirme yapılmamıştır.

Demografi: 2 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirmesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 166/dk | Solunum: 62/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,77 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek santral siyanozedir ve takipneiktir.
- Oksijen verilmesine rağmen satürasyon %76-80 arasında seyretmektedir.
- Üfürüm hafif duyulmaktadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hiperoksi testi

Etiket: Hiperoksi testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek akım oksijene rağmen oksijen satürasyonunda belirgin düzelme olmadı. | Klinik anlam: Kardiyak sağ-sol şant veya duktus bağımlı dolaşımı düşündürür. | Sonuç yorumu: Kardiyak sağ-sol şant veya duktus bağımlı dolaşımı düşündürür. | Sonuç başlığı: Hiperoksi testi | Sonuç özeti: Yüksek akım oksijene rağmen oksijen satürasyonunda belirgin düzelme olmadı. | Yorum: Kardiyak sağ-sol şant veya duktus bağımlı dolaşımı düşündürür. | Satırlar: Hiperoksi testi | Yüksek akım oksijene rağmen oksijen satürasyonunda belirgin düzelme olmadı. // Kardiyak sağ-sol şant veya duktus bağımlı dolaşımı düşündürür.

Tetkik 2: Kan gazı

Etiket: Kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hipoksemi ve metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Sistemik perfüzyon bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Sistemik perfüzyon bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Kan gazı | Sonuç özeti: Hipoksemi ve metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Sistemik perfüzyon bozukluğunu destekler. | Satırlar: Kan gazı / pH 7.25 / pH 7.35-7.45 / Sistemik perfüzyon bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Ekokardiyografi beklenirken bu yenidoğanda ilk başlanması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prostaglandin E1 infüzyonu
B) İndometazin tedavisi
C) Oral beslenmenin artırılması
D) Yüksek doz diüretik tedaviyle ayaktan izlem planlamak
E) Rutin fototerapi

Doğru Cevap: Prostaglandin E1 infüzyonu

A) Prostaglandin E1 infüzyonu: Prostaglandin E1 infüzyonu duktus arteriozus açıklığını koruyarak duktus bağımlı dolaşımda hayat kurtarıcı köprü tedavisi sağlar. Vakadaki “Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.” ve “Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) İndometazin tedavisi: İndometazin prostaglandin sentezini azaltarak duktusu kapatabilir ve duktus bağımlı hastada dolaşımı kötüleştirir. Bu olguda “Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.” ve “Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Prostaglandin E1 infüzyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Oral beslenmenin artırılması: Vakadaki Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir ve Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır. Bu olguda “Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.” ve “Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Prostaglandin E1 infüzyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Yüksek doz diüretik tedaviyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir ve Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır. Bu olguda “Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.” ve “Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Prostaglandin E1 infüzyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Rutin fototerapi: Fototerapi hiperbilirubinemi tedavisidir; dirençli siyanoz ve duktus bağımlı dolaşımı tedavi etmez. Bu olguda “Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.” ve “Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Prostaglandin E1 infüzyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda dirençli siyanoz olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.” ve “Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.” birlikte okunduğunda Prostaglandin E1 infüzyonu seçeneği öne çıkar; “Zayıf femoral nabız ve metabolik asidoz sistemik dolaşım etkilenimini düşündürür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Doğumdan sonra duktusun kapanmaya başlamasıyla kötüleşen dirençli siyanoz, zayıf femoral nabız ve asidoz duktus bağımlı konjenital kalp hastalığını düşündürür. Ekokardiyografi beklenirken duktus arteriozus açıklığını sürdürmek için prostaglandin E1 infüzyonu başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.”, “Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.” ve “Zayıf femoral nabız ve metabolik asidoz sistemik dolaşım etkilenimini düşündürür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Prostaglandin E1 infüzyonu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Siyanoz doğumdan sonraki ikinci günde giderek belirginleşmiştir.

Kanıt 2: Oksijen desteğine rağmen satürasyonda anlamlı düzelme olmamıştır.

Kanıt 3: Zayıf femoral nabız ve metabolik asidoz sistemik dolaşım etkilenimini düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Duktus bağımlı kalp hastalığı şüphesinde ekokardiyografi beklenirken prostaglandin E1 başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 151: v180-new-151-kemoterapi-sonrasi-ates

Başlık: Kemoterapi sonrası ateş

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Acil öncelik ve ilk basamak yönetimini seçme.

Learning Target: Febril nötropenide ilk saat antibiyotik tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, kemoterapi sonrası gelişen ateş ve halsizlik nedeniyle acile getiriliyor. Akut lenfoblastik lösemi nedeniyle kemoterapi aldığı ve son kürden 7 gün sonra ateşinin başladığı öğreniliyor. Evde ölçülen ateş 38.6°C'dir ve belirgin enfeksiyon odağı tariflenmemektedir.

Demografi: 8 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 96/58 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 38.7°C | Şok indeksi: 1,33 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk halsiz ancak koopere görünümündedir.
- Ağız mukozasında hafif mukozit vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Mutlak nötrofil sayısı

Etiket: Mutlak nötrofil sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Ağır nötropeni mevcuttur. | Sonuç yorumu: Ağır nötropeni mevcuttur. | Sonuç başlığı: Mutlak nötrofil sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Ağır nötropeni mevcuttur. | Satırlar: Mutlak nötrofil sayısı / Belirgin düşük saptandı. / 220 /mm³; Referans: >1500 /mm³ / Ağır nötropeni mevcuttur.

Tetkik 2: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Enflamatuvar süreci destekler. | Sonuç yorumu: Enflamatuvar süreci destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Enflamatuvar süreci destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / Yüksek saptandı. / 78 mg/L; Referans: <5 mg/L / Enflamatuvar süreci destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta kan kültürü alındıktan sonra ilk saat içinde başlanması gereken en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması
B) Antipiretik tedaviyle kültür sonucuna göre izlem planlamak
C) Oral amoksisilin-klavulanat ile ayaktan izlem planlamak
D) Nötrofil sayısı normale dönene kadar antibiyotik verilmemesi
E) Rutin antiviral tedaviyle izlem yapılması

Doğru Cevap: Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması

- A) Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması: Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik febril nötropenide ilk saat içinde başlanması gereken uygun tedavidir. Vakadaki "Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir." ve "Ateşi 38.7°C ölçülmüştür." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- B) Antipiretik tedaviyle kültür sonucuna göre izlem planlamak: Vakadaki Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir ve Ateşi 38.7°C ölçülmüştür. Bu olguda "Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir." ve "Ateşi 38.7°C ölçülmüştür." ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Oral amoksisilin-klavulanat ile ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir ve Ateşi 38.7°C ölçülmüştür. Bu olguda "Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir." ve "Ateşi 38.7°C ölçülmüştür." ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nötrofil sayısı normale dönene kadar antibiyotik verilmemesi: Vakadaki Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir ve Ateşi 38.7°C ölçülmüştür. Bu olguda "Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir." ve "Ateşi 38.7°C ölçülmüştür." ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Rutin antiviral tedaviyle izlem yapılması: Rutin antiviral tedavi bakteriyel sepsis riskini kapsamaz ve febril nötropeninin standart ilk yaklaşımı değildir. Bu olguda "Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir." ve "Ateşi 38.7°C ölçülmüştür." ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kemoterapi sonrası ateş olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir." ve "Ateşi 38.7°C ölçülmüştür." birlikte okunduğunda Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması seçeneği öne çıkar; "Mutlak nötrofil sayısı ağır nötropeni düzeyindedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kemoterapi alan çocukta ateş ve ağır nötropeni febril nötropeni acilidir. Odak belirgin olmasa bile bakteriyemi ve sepsis riski yüksek olduğundan kan kültürü alındıktan sonra ilk saat içinde antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir.", "Ateşi 38.7°C ölçülmüştür." ve "Mutlak nötrofil sayısı ağır nötropeni düzeyindedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Antipseudomonal etkili intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk kemoterapi sonrası dönemdedir.

Kanıt 2: Ateşi 38.7°C ölçülmüştür.

Kanıt 3: Mutlak nötrofil sayısı ağır nötropeni düzeyindedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Febril nötropeni, odak olmasa bile acil antibiyotik gerektirir; tedavi kültür sonucu beklenerek geciktirilmez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 152: v180-new-152-ani-baslayan-carpinti

Başlık: Ani başlayan çarpıntı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Hemodinamik olarak stabil çocukta supraventriküler taşikardi tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, ani başlayan çarpıntı ve göğüs rahatsızlık hissi nedeniyle acile getiriliyor. Şikâyetin okulda aniden başladığı, daha önce kısa süren benzer ataklar yaşadığı ancak kendiliğinden düzeldiği öğreniliyor. Senkop, travma veya ilaç alımı tariflenmiyor.

Demografi: 10 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 108/68 mmHg | Nabız: 214/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %99% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,98 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk uyanık ve konuşabilir durumdadır.
- Periferik perfüzyonu iyidir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Dar QRS kompleksli, düzenli taşikardi izlendi; P dalgaları seçilemedi. | Klinik anlam: Supraventriküler taşikardi ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Supraventriküler taşikardi ile uyumludur. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Dar QRS kompleksli, düzenli taşikardi izlendi; P dalgaları seçilemedi. | Yorum: Supraventriküler taşikardi ile uyumludur. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Dar QRS kompleksli, düzenli taşikardi izlendi; P dalgaları seçilemedi. // Supraventriküler taşikardi ile uyumludur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-086 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Dar QRS kompleksli, düzenli taşikardi izlendi; P dalgaları seçilemedi. | Klinik anlam: Supraventriküler taşikardi ile uyumludur. | URL: https://iukbtlkzictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/086_086-supraventrikuler-tasikardi-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/086_086-supraventrikuler-tasikardi-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Dar QRS kompleksli, düzenli taşikardi izlendi; P dalgaları seçilemedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Vagal manevralara yanıt alınamayan bu stabil çocukta en uygun sonraki tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması
B) Senkronize kardiyoversiyonun sedasyonsuz hemen uygulanması
C) Oral beta bloker reçete edilip eve gönderilmesi
D) Defibrilasyon uygulanması
E) Rutin antibiyotik başlanması

Doğru Cevap: Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması

A) Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması: Hızlı intravenöz adenoazin stabil dar kompleks supraventriküler taşikardide vagal manevra sonrası uygun tedavidir. Vakadaki “Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.” ve “Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Senkronize kardiyoversiyonun sedasyonsuz hemen uygulanması: Senkronize kardiyoversiyon hemodinamik instabilite varsa önceliklidir; bu çocuk stabil olduğu için adenoazin uygundur. Bu olguda “Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.” ve “Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Oral beta bloker reçete edilip eve gönderilmesi: Oral beta bloker akut hızlı ritmi güvenli şekilde sonlandırmak için uygun acil tedavi değildir. Bu olguda “Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.” ve “Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Defibrilasyon uygulanması: Defibrilasyon nabızsız ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardide kullanılır; bu çocukta düzenli dar kompleks supraventriküler taşikardi vardır. Bu olguda “Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.” ve “Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Rutin antibiyotik başlanması: Vakadaki Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır ve Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir. Bu olguda “Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.” ve “Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani başlayan çarpıntı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.” ve “Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.” birlikte okunduğunda Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması seçeneği öne çıkar; “Vagal manevralara yanıt alınamamıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Dar QRS kompleksli düzenli taşikardi ve hemodinamik stabilite pediatrik supraventriküler taşikardiyi düşündürür. Stabil hastada vagal manevralar başarısızsa atriyoventriküler nodu geçici bloke eden hızlı intravenöz adenoazin uygun akut tedavidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.”, “Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.” ve “Vagal manevralara yanıt alınamamıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hızlı intravenöz adenoazin uygulanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Elektrokardiyografide dar QRS kompleksli düzenli taşikardi vardır.

Kanıt 2: Çocuk uyanık, perfüzyonu iyi ve kan basıncı stabildir.

Kanıt 3: Vagal manevralara yanıt alınamamıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Stabil çocuk SVT’de vagal manevra sonrası ilk ilaç adenozindir; instabilite varsa senkronize kardiyoversiyon gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 153: v180-new-153-ates-ve-ense-sertligi

Başlık: Ateş ve ense sertliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve ilk basamak yönetimini seçme.

Learning Target: Akut bakteriyel menenjit şüphesinde antibiyotik tedavisini geciktirmeme ilkesini uygulayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma nedeniyle acile getiriliyor. Son 12 saattir ateşinin yükseldiği, baş ağrısının arttığı ve iki kez kustuğu öğreniliyor. Ailesi çocuğun giderek uykuya eğilimli hale geldiğini belirtiyor.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 39.3°C | Şok indeksi: 1,40 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk uykuya eğilimlidir ancak uyandırılabilir.
- Ense sertliği ve fotofobi vardır.
- Peteşi izlenmez

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / Yüksek saptandı. / 19800 /mm³; Referans: 5000-15000 /mm³ / Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler.

Tetkik 2: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ciddi inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Ciddi inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Ciddi inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / Yüksek saptandı. / 116 mg/L; Referans: <5 mg/L / Ciddi inflamasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Lomber ponksiyon kısa süre gecikecekse bu çocukta en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak
- B) Lomber ponksiyon yapılanaya kadar antibiyotiği kesinlikle ertelemek
- C) Oral ateş düşürücü verip eve göndermek
- D) Antibiyotik yerine antiviral tedavi başlamak
- E) Kültür sonuçları çıkana kadar tüm tedavileri durdurmak

Doğru Cevap: Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak

A) Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak: Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak, lomber ponksiyon gecikecek menenjit şüphesinde doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Lomber ponksiyon yapılanaya kadar antibiyotiği kesinlikle ertelemek: Antibiyotiği lomber ponksiyon yapılanaya kadar ertelemek bakteriyel menenjitte morbidite ve mortaliteyi artırabilir. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Oral ateş düşürücü verip eve göndermek: Vakadaki Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır ve Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Antibiyotik yerine antiviral tedavi başlamak: Vakadaki Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır ve Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kültür sonuçları çıkana kadar tüm tedavileri durdurmak: Vakadaki Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır ve Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve ense sertliği olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.” birlikte okunduğunda Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak seçeneği öne çıkar; “Uykuya eğilim bilinç etkilenimini göstermektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yüksek ateş, ense sertliği, fotofobi, kusma ve bilinç değişikliği akut bakteriyel menenjit düşündürür. Lomber ponksiyon gecikecekse kan kültürü alındıktan sonra ampirik intravenöz antibiyotik gecikmeden başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.”, “Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.” ve “Uykuya eğilim bilinç etkilenimini göstermektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotiği hemen başlamak en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Yüksek ateş, baş ağrısı ve kusma vardır.

Kanıt 2: Ense sertliği ve fotofobi meningeal irritasyonu destekler.

Kanıt 3: Uykuya eğilim bilinç etkilenimini göstermektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Menenjit şüphesinde lomber ponksiyon gecikecekse antibiyotik geciktirilmez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 154: v180-new-154-aclik-sonrasi-nobet

Başlık: Açlık sonrası nöbet

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve ilk basamak yönetimini seçme.

Learning Target: Çocukta hipoglisemik nöbette ilk düzeltici tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, sabah uyanmadan önce gelişen jeneralize nöbet nedeniyle acile getiriliyor. Bir gündür kusma ve iştahsızlık nedeniyle çok az beslendiği öğreniliyor. Nöbet yaklaşık 3 dakika sürmüş ve acile geldiğinde çocuk uykuya eğilimli kalmıştır. Bilinen epilepsi tanısı yoktur.

Demografi: 2 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,50 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk letarjik ve soluk görünümündedir.
- Dehidratasyon bulguları hafiftir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Semptomatik hipoglisemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Semptomatik hipoglisemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Semptomatik hipoglisemiyi gösterir. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / Belirgin düşük saptandı. / 32 mg/dL; Referans: 70-140 mg/dL / Semptomatik hipoglisemiyi gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması
B) Oral karbonhidrat vererek klinik yanıtı izlemek
C) Antiepileptik idame tedavisiyle ayaktan izlem planlamak
D) Ateş düşürücü verilmesi
E) İnsülin uygulanması

Doğru Cevap: İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması

A) İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması: İntravenöz dekstroz bolusu bilinç etkilenimi ve nöbetle seyreden ciddi hipoglisemiyi hızla düzeltir. Vakadaki "Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir." ve "Nöbet sonrası letarji devam etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
B) Oral karbonhidrat vererek klinik yanıtı izlemek: Vakadaki Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir ve Nöbet sonrası letarji devam etmektedir. Bu olguda "Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir." ve "Nöbet sonrası letarji devam etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Antiepileptik idame tedavisiyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir ve Nöbet sonrası letarji devam etmektedir. Bu olguda "Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir." ve "Nöbet sonrası letarji devam etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Ateş düşürücü verilmesi: Vakadaki Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir ve Nöbet sonrası letarji devam etmektedir. Bu olguda "Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir." ve "Nöbet sonrası letarji devam etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) İnsülin uygulanması: Vakadaki Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir ve Nöbet sonrası letarji devam etmektedir. Bu olguda "Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir." ve "Nöbet sonrası letarji devam etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlık sonrası nöbet olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir." ve "Nöbet sonrası letarji devam etmektedir." birlikte okunduğunda İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması seçeneği öne çıkar; "Kapiller kan glukozu belirgin düşük ölçülmüştür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nöbet sonrası bilinç etkilenimi olan çocukta kapiller glukozun 32 mg/dL saptanması semptomatik ciddi hipoglisemiyi gösterir. Bilinci tam açık olmayan hastada oral alım aspirasyon riski taşır; ilk tedavi intravenöz dekstroz bolusudur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir.", "Nöbet sonrası letarji devam etmektedir." ve "Kapiller kan glukozu belirgin düşük ölçülmüştür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz dekstroz bolusu uygulanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk bir gündür yeterli beslenememiştir.

Kanıt 2: Nöbet sonrası letarji devam etmektedir.

Kanıt 3: Kapiller kan glukozu belirgin düşük ölçülmüştür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Bilinç etkilenimi olan hipoglisemik çocukta oral şeker değil intravenöz dekstroz verilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 155: v180-new-155-sicak-ortamda-bilinc-degisikligi

Başlık: Sıcak ortamda bilinç değişikliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve ilk basamak yönetimini seçme.

Learning Target: Pediatrik sıcak çarpmasında hızlı soğutmanın önceliğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, sıcak havada futbol antrenmanı sonrası bilinç bulanıklığı ve bayılma nedeniyle acile getiriliyor. Antrenman sırasında yeterince sıvı alamadığı, sonrasında baş dönmesi ve konfüzyon geliştiği öğreniliyor. Nöbet öyküsü yoktur.

Demografi: 13 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 92/56 mmHg | Nabız: 152/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 40.8°C | Şok indeksi: 1,65 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk konfüzedir, cildi sıcak ve kurudur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kreatin kinaz

Etiket: Kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Isı ilişkili kas hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Isı ilişkili kas hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Kreatin kinaz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Isı ilişkili kas hasarını destekler. | Satırlar: Kreatin kinaz / Yüksek saptandı. / 1800 U/L; Referans: 30-200 U/L / Isı ilişkili kas hasarını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk ve en kritik acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi
B) Oral sıvı ve gölgede soğutmayla klinik izlem
C) Antipiretik tedaviyle ayaktan izlem planlama
D) Antibiyotik başlanıp kültür sonucuna göre izlem planlama
E) Soğutmayı laboratuvar sonuçları çıkana kadar erteleme

Doğru Cevap: Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi

A) Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi: Hızlı aktif soğutma ve destek tedavisi sıcak çarpmasında organ hasarını azaltan en kritik ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.” ve “Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Oral sıvı ve gölgede soğutmayla klinik izlem: Vakadaki Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir ve Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür. Bu olguda “Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.” ve “Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Antipiretik tedaviyle ayaktan izlem planlama: Vakadaki Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir ve Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür. Bu olguda “Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.” ve “Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Antibiyotik başlanıp kültür sonucuna göre izlem planlama: Vakadaki Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir ve Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür. Bu olguda “Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.” ve “Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Soğutmayı laboratuvar sonuçları çıkana kadar erteleme: Soğutmayı laboratuvar sonuçları çıkana kadar ertelemek organ hasarı ve mortalite riskini artırır. Bu olguda “Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.” ve “Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sıcak ortamda bilinç değişikliği olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.” ve “Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.” birlikte okunduğunda Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi seçeneği öne çıkar; “Kreatin kinaz yüksekliği ısı ilişkili kas hasarını desteklemektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Egzersiz ve sıcak maruziyeti sonrası 40°C üzerinde hipertermi ve bilinç değişikliği sıcak çarpmasını gösterir. Tedavide mortaliteyi azaltan temel basamak gecikmeden hızlı aktif soğutmadır; sıvı ve organ desteği eş zamanlı sağlanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.”, “Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.” ve “Kreatin kinaz yüksekliği ısı ilişkili kas hasarını desteklemektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hızlı aktif soğutma ve eş zamanlı destek tedavisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bilinç değişikliği sıcak havada yoğun egzersiz sonrası gelişmiştir.

Kanıt 2: Rektal sıcaklık 40.8°C ölçülmüştür.

Kanıt 3: Kreatin kinaz yüksekliği ısı ilişkili kas hasarını desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Sıcak çarpmasında ateş düşürücü değil hızlı aktif soğutma hayat kurtarıcıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 156: v180-new-156-kafa-travmasi-sonrasi-yeniden-bilinc-kaybi

Başlık: Kafa travması sonrası yeniden bilinç kaybı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik ve objektif bulgularla en olası tanıyı seçme.

Learning Target: Çocukta kafa travmasında epidural hematoma bulgularını tanı açısından değerlendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, bisikletten düşme sonrası baş ağrısı ve bilinçte kötüleşme nedeniyle acile getiriliyor. Düşme sonrası kısa süre bayıldığı, ardından yaklaşık bir saat iyi görüldüğü ve konuştuğu öğreniliyor. Daha sonra şiddetli baş ağrısı, kusma ve uykuya eğilim gelişmiştir. Kask kullanmadığı belirtiliyor.

Demografi: 12 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 142/84 mmHg | Nabız: 58/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 0,41

Fizik Muayene

- Çocuk somnolandır
- Sağ temporal bölgede hassas şişlik vardır.
- Sol pupil sağa göre daha geniş ve ışık yanıtı zayıftır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Acil kraniyal bilgisayarlı tomografi

Etiket: Acil kraniyal bilgisayarlı tomografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Temporal bölgede bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti izlendi. | Klinik anlam: Acil nöroşirürjik değerlendirme gerektirir. | Sonuç yorumu: Acil nöroşirürjik değerlendirme gerektirir. | Sonuç başlığı: Acil kraniyal bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Temporal bölgede bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti izlendi. | Yorum: Acil nöroşirürjik değerlendirme gerektirir. | Satırlar: Acil kraniyal bilgisayarlı tomografi / Temporal bölgede bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti izlendi. // Acil nöroşirürjik değerlendirme gerektirir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-087 | Başlık: Acil kraniyal bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Temporal bölgede bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti izlendi. | Klinik anlam: Acil nöroşirürik değerlendirme gerektirir. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/087_087-epidural-hematom-kraniyal-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/087_087-epidural-hematom-kraniyal-bt.webp | Alt text: Acil kraniyal bilgisayarlı tomografi - Temporal bölgede bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Epidural hematoma
- B) Subaraknoid kanama
- C) Diffüz aksonal hasar
- D) Basit skalp hematoma
- E) Migren atağı

Doğru Cevap: Epidural hematoma

A) Epidural hematoma: Epidural hematoma lucid interval, temporal travma ve bikonveks ekstraaksiyel kanama bulgularıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir." ve "Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Subaraknoid kanama: Subaraknoid kanama genellikle sulkus ve sisternalarda kanla izlenir; bikonveks ekstraaksiyel hematoma paterni epidural kanamaya uyar. Bu olguda "Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir." ve "Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir." ipuçları tanısallık açısından Epidural hematoma seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Diffüz aksonal hasar: Diffüz aksonal hasarda sıklıkla uzamış koma ve yaygın mikroskobik aksonal yaralanma beklenir; lucid interval ve bikonveks hematoma tipik değildir. Bu olguda "Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir." ve "Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir." ipuçları tanısallık açısından Epidural hematoma seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Basit skalp hematoma: Vakadaki Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir ve Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir. Bu olguda "Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir." ve "Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir." ipuçları tanısallık açısından Epidural hematoma seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Migren atağı: Vakadaki Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir ve Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir. Bu olguda "Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir." ve "Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir." ipuçları tanısallık açısından Epidural hematoma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kafa travması sonrası yeniden bilinç kaybı olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. "Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir." ve "Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir." birlikte okunduğunda Epidural hematoma seçeneği öne çıkar; "BT'de bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti gösterilmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kafa travması sonrası kısa bilinç kaybı, ardından lucid interval ve sonrasında hızlı nörolojik kötüleşme epidural hematoma için klasiktir. Temporal travma orta meningeal arter yaralanmasına yol açabilir; bilgisayarlı tomografide bikonveks ekstraaksiyel hematoma tipiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir.", "Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir." ve "BT'de bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti gösterilmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Epidural hematoma en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Travma sonrası kısa bilinç kaybını geçici düzelleme dönemi izlemiştir.

Kanıt 2: Daha sonra baş ağrısı, kusma ve somnolans gelişmiştir.

Kanıt 3: BT'de bikonveks hiperdens ekstraaksiyel kanama ve orta hat şifti gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Epidural hematoma'da lucid interval ve bikonveks BT görünümü klasik ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 157: v180-new-157-yenidoganda-kasilma-ve-jitteriness

Başlık: Yenidoğanda kasılma ve jitteriness

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Yenidoğanda hipokalsemik tetanide acil kalsiyum tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, tekrarlayan kasılma benzeri hareketler ve beslenmede azalma nedeniyle getiriliyor. Term doğduğu, annede diyabet öyküsü olduğu öğreniliyor. Son 12 saatte irkilme, çene titremesi ve kısa süreli kasılma atakları fark edilmiştir. Ateş veya travma öyküsü yoktur.

Demografi: 5 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan acilinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 148/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek iritabl ve jittery görünmektedir.
- Perioral seğirme izlenir.
- Kardiyak oskültasyon doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum total kalsiyum

Etiket: Serum total kalsiyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Semptomatik hipokalsemiyi destekler. | Sonuç yorumu: Semptomatik hipokalsemiyi destekler. | Sonuç başlığı: Serum total kalsiyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Semptomatik hipokalsemiyi destekler. | Satırlar: Serum total kalsiyum / Düşük saptandı. / 6.2 mg/dL; Referans: 8.5-10.5 mg/dL / Semptomatik hipokalsemiyi destekler.

Tetkik 2: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır. | Sonuç yorumu: Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / Normal saptandı. / 82 mg/dL; Referans: 45-100 mg/dL yenidoğan için / Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yenidoğanda en uygun acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi
- B) Oral D vitamini başlanıp eve gönderilmesi
- C) İnsülin infüzyonu başlanması
- D) Acil antibiyotik başlanıp kalsiyumun izlenmemesi
- E) Sodyum bikarbonat bolusu verilmesi

Doğru Cevap: Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi

A) Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi: Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat semptomatik yenidoğan hipokalsemisinde uygun acil tedavidir. Vakadaki “Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.” ve “Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Oral D vitamini başlanıp eve gönderilmesi: Vakadaki Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır ve Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür. Bu olguda “Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.” ve “Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) İnsülin infüzyonu başlanması: Vakadaki Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır ve Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür. Bu olguda “Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.” ve “Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Acil antibiyotik başlanıp kalsiyumun izlenmemesi: Antibiyotik enfeksiyon şüphesinde değerlendirilebilir ancak burada gösterilen acil düzeltilebilir neden hipokalsemidir. Bu olguda “Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.” ve “Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Sodyum bikarbonat bolusu verilmesi: Vakadaki Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır ve Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür. Bu olguda “Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.” ve “Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda kasılma ve jitteriness olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.” ve “Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.” birlikte okunduğunda Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneği öne çıkar; “Kapiller glukoz normal olduğu için hipoglisemi ön planda değildir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda jitteriness, perioral seğirme ve düşük serum kalsiyumu semptomatik hipokalsemiyi gösterir. Semptomatik yenidoğanda acil tedavi kardiyak monitörizasyon altında dikkatli intravenöz kalsiyum glukonat verilmesidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.”, “Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.” ve “Kapiller glukoz normal olduğu için hipoglisemi ön planda değildir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kardiyak monitörizasyon altında intravenöz kalsiyum glukonat verilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte jitteriness, perioral seğirme ve kasılma benzeri ataklar vardır.

Kanıt 2: Serum kalsiyumu semptomatik düzeyde düşüktür.

Kanıt 3: Kapiller glukoz normal olduğu için hipoglisemi ön planda değildir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Semptomatik yenidoğan hipokalsemisinde intravenöz kalsiyum glukonat monitörizasyonla verilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 158: v180-new-158-bas-agrisi-ve-yuksek-tansiyon

Başlık: Baş ağrısı ve yüksek tansiyon

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta hipertansif acilde hedef organ bulgularıyla intravenöz tedavi gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, şiddetli baş ağrısı, bulanık görme ve kusma nedeniyle acile getiriliyor. Son haftalarda sabah baş ağrılarının arttığı, bugün görme bulanıklığı ve kusmanın eklendiği öğreniliyor. Daha önce böbrek hastalığı nedeniyle takip edildiği ancak kontrollerine düzenli gitmediği belirtiliyor.

Demografi: 14 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 198/126 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 0,53

Fizik Muayene

- Çocuk ajite ve fotofobiktir.
- Fundoskopide papil ödemi şüphesi vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Böbrek etkilenimini destekler. | Sonuç yorumu: Böbrek etkilenimini destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Böbrek etkilenimini destekler. | Satırlar: Serum kreatinin / Yüksek saptandı. / 2.4 mg/dL; Referans: 0.5-1.0 mg/dL / Böbrek etkilenimini destekler.

Tetkik 2: İdrar analizi

Etiket: İdrar analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Proteinüri ve mikroskobik hematüri saptandı. | Klinik anlam: Renal hastalık zeminini destekler. | Sonuç yorumu: Renal hastalık zeminini destekler. | Sonuç başlığı: İdrar analizi | Sonuç özeti: Proteinüri ve mikroskobik hematüri saptandı. | Yorum: Renal hastalık zeminini destekler. | Satırlar: İdrar analizi / Proteinüri ve mikroskobik hematüri saptandı. // Renal hastalık zeminini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil kan basıncı yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi
- B) Kan basıncının oral ilaçla haftalar içinde yavaşça değerlendirilmesi

- C) Kan basıncının hemen normal değerlere kadar hızla düşürülmesi
D) Analjezik tedaviyle ayaktan izlem planlamak
E) Hipertansiyonun büyüme çağında normal kabul edilmesi

Doğru Cevap: Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi

A) Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi: Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü düşüş hedef organ bulguları olan hipertansif acilde uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.” ve “Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Kan basıncının oral ilaçla haftalar içinde yavaşça değerlendirilmesi: Haftalar içinde oral ilaçla değerlendirme hedef organ bulguları olan acil hipertansiyonda tedaviyi geciktirir. Bu olguda “Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.” ve “Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Kan basıncının hemen normal değerlere kadar hızla düşürülmesi: Kan basıncını hemen normal değerlere indirmek serebral ve renal hipoperfüzyon riskini artırabilir. Bu olguda “Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.” ve “Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Analjezik tedaviyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür ve Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür. Bu olguda “Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.” ve “Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Hipertansiyonun büyüme çağında normal kabul edilmesi: Vakadaki Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür ve Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür. Bu olguda “Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.” ve “Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Baş ağrısı ve yüksek kan basıncı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.” ve “Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.” birlikte okunduğunda Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi seçeneği öne çıkar; “Kreatinin yüksekliği ve idrar bulguları renal hastalık zeminini destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çok yüksek kan basıncıyla birlikte baş ağrısı, kusma, görme bulanıklığı ve papil ödemi şüphesi hipertansif acili düşündürür. Tedavide yoğun izlem altında intravenöz antihipertansiflerle kan basıncı kontrollü şekilde düşürülür; ani aşırı düşüş perfüzyonu bozabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.”, “Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.” ve “Kreatinin yüksekliği ve idrar bulguları renal hastalık zeminini destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Yoğun izlem altında intravenöz antihipertansif ile kontrollü kan basıncı düşürülmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kan basıncı 198/126 mmHg olarak ağır yüksek ölçülmüştür.

Kanıt 2: Baş ağrısı, kusma, bulanık görme ve papil ödemi şüphesi hedef organ etkilenimini düşündürür.

Kanıt 3: Kreatinin yüksekliği ve idrar bulguları renal hastalık zeminini destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Hipertansif acilde basınç düşürülür ama aniden normale indirilmez; kontrollü intravenöz tedavi gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 159: v180-new-159-kulak-agrısı-sonrası-kulak-arkasında-sislik

Başlık: Kulak ağrısı sonrası kulak arkasında şişlik

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Akut otitis media komplikasyonu olan mastoiditte acil yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, ateş, kulak ağrısı ve kulak arkasında şişlik nedeniyle acile getiriliyor. Bir haftadır sağ kulak ağrısı ve ateşi olduğu, son iki gündür kulak arkasında kızarıklık ve şişlik geliştiği öğreniliyor. Daha önce verilen oral antibiyotiği düzensiz kullanmıştır.

Demografi: 4 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.8°C | Şok indeksi: 1,22 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ aurikula öne ve dışa doğru itilmiş görünmektedir.
- Sağ mastoid bölgede eritem, şişlik ve belirgin hassasiyet vardır.
- Otoskopide sağ timpan membran hiperemik ve bombe görünür.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi

Etiket: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sağ mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon ve kortikal inceltme izlendi. | Klinik anlam: Akut mastoidit komplikasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Akut mastoidit komplikasyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Sağ mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon ve kortikal inceltme izlendi. | Yorum: Akut mastoidit komplikasyonunu destekler. | Satırlar: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi / Sağ mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon ve kortikal inceltme izlendi. // Akut mastoidit komplikasyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-088 | Başlık: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Sağ mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon ve kortikal inceltme izlendi. | Klinik anlam: Akut mastoidit komplikasyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/088_088-akut-mastoidit-temporal-kemik-bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/088_088-akut-mastoidit-temporal-kemik-bt.webp | Alt text: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi - Sağ mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon ve kortikal inceltme izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi
B) Analjezik tedaviyle ayaktan izlem planlamak
C) Alerji testi yapılması
D) Oral antihistaminik ile izlem
E) Yüksek doz oral amoksisilin-klavulanat ile 48 saat yakın poliklinik izlemi planlamak

Doğru Cevap: Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi

A) Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi: Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi mastoidit komplikasyonunda uygun acil yaklaşımdır. Vakadaki “Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.” ve “Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Analjezik tedaviyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır ve Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır. Bu olguda “Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.” ve “Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Alerji testi yapılması: Vakadaki Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır ve Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır. Bu olguda “Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.” ve “Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral antihistaminik ile izlem: Vakadaki Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır ve Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır. Bu olguda “Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.” ve “Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Yüksek doz oral amoksisilin-klavulanat ile 48 saat yakın poliklinik izlemi planlamak: Vakadaki Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır ve Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır. Bu olguda “Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.” ve “Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekeç / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kulak ağrısı sonrası kulak arkasında şişlik olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.” ve “Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.” birlikte okunduğunda Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi seçeneği öne çıkar; “Aurikula öne-dışa itilmiş ve BT’de mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Akut otitis media sonrası ateş, mastoid bölgede eritem-şişlik-hassasiyet ve aurikulanın öne itilmesi akut mastoiditi düşündürür. Bu tablo intrakraniyal ve kemik komplikasyon riski taşıdığı için hastaneye yatış, intravenöz antibiyotik ve kulak burun boğaz değerlendirmesi gerektirir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.”, “Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.” ve “Aurikula öne-dışa itilmiş ve BT’de mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hastaneye yatırılarak intravenöz antibiyotik başlanması ve kulak burun boğaz değerlendirmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kulak ağrısı ve ateş akut otitis media süreciyle başlamıştır.

Kanıt 2: Mastoid bölgede eritem, şişlik ve hassasiyet vardır.

Kanıt 3: Aurikula öne-dışa itilmiş ve BT’de mastoid hava hücrelerinde opasifikasyon izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Mastoidit akut otitis media komplikasyonudur; intravenöz antibiyotik ve KBB değerlendirmesi gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 160: v180-new-160-kapali-ortam-sonrasi-bas-agrisi

Başlık: Kapalı ortam sonrası baş ağrısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta karbonmonoksit zehirlenmesinde oksijen tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, baş ağrısı, bulantı ve uykuya eğilim nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi, çocuğun soba kullanılan kapalı odada birkaç saat kaldığını ve aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı geliştiğini belirtiyor. Travma veya ateş öyküsü yoktur.

Demografi: 9 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisinde

Vital Bulgular

Kan basıncı: 106/64 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %99 | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk uykuya eğilimli ancak uyandırılabilir durumdadır.
- Cilt rengi normaldir
- Akciğer sesleri doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ko-oksimeetri

Etiket: Ko-oksimeetri | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Karboksihemoglobinin düzeyi yüksek saptandı. | Klinik anlam: Karbonmonoksit maruziyetini destekler. | Sonuç yorumu: Karbonmonoksit maruziyetini destekler. | Sonuç başlığı: Ko-oksimeetri | Sonuç özeti: Karboksihemoglobinin düzeyi yüksek saptandı. | Yorum: Karbonmonoksit maruziyetini destekler. | Satırlar: Ko-oksimeetri / Karboksihemoglobinin düzeyi yüksek saptandı. / 24 %; Referans: <3% sigara içmeyenlerde / Karbonmonoksit maruziyetini destekler.

Tetkik 2: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Doku hipoksisini düşündürür. | Sonuç yorumu: Doku hipoksisini düşündürür. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Doku hipoksisini düşündürür. | Satırlar: Serum laktat / Yüksek saptandı. / 3.9 mmol/L; Referans: 0.5-2.2 mmol/L / Doku hipoksisini düşündürür.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi
- B) Pulse oksimetre normal olduğu için ayaktan izlem planlanması
- C) Antibiyotik başlanması
- D) Asetilsalisilik asit verilmesi
- E) İnsülin infüzyonu başlanması

Doğru Cevap: Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi

A) Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi: Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen karboksihemoglobinin yarı ömrünü azaltarak karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk tedavidir. Vakadaki “Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.” ve “Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Pulse oksimetre normal olduğu için ayaktan izlem planlanması: Vakadaki Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır ve Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir. Bu olguda “Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.” ve “Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek akımlı yüzde yüz

oksijen verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Antibiyotik başlanması: Vakadaki Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır ve Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir. Bu olguda “Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.” ve “Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Asetilsalisilik asit verilmesi: Asetilsalisilik asit bu zehirlenmenin antidodu değildir ve çocuklarda gereksiz kullanım risklidir. Bu olguda “Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.” ve “Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) İnşülin infüzyonu başlanması: Vakadaki Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır ve Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir. Bu olguda “Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.” ve “Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kapalı ortam sonrası baş ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.” ve “Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi seçeneği öne çıkar; “Karboksihemoglobinin düzeyi yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kapalı ortam soba maruziyeti, ailede benzer yakınmalar, nörolojik semptomlar ve yüksek karboksihemoglobinin karbonmonoksit zehirlenmesini gösterir. Pulse oksimetre yalancı normal olabilir; ilk tedavi karbonmonoksitin hemoglobinden ayrılmasını hızlandırmak için yüksek akımlı yüzde yüz oksijendir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.”, “Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.” ve “Karboksihemoglobinin düzeyi yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Yüksek akımlı yüzde yüz oksijen verilmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kapalı soba ortamında maruziyet öyküsü vardır.

Kanıt 2: Aynı evdeki başka kişilerde de baş ağrısı gelişmiştir.

Kanıt 3: Karboksihemoglobinin düzeyi yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Karbonmonoksit zehirlenmesinde pulse oksimetre yanıltıcı olabilir; tedavi yüksek akımlı yüzde yüz oksijendir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 161: v181-new-161-yenidoganda-beslenme-bozulmasi-ve-hipotermi

Başlık: Yenidoğanda beslenme bozulması ve hipotermi

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Yenidoğan sepsisinde klinik bulgularla ampirik antibiyotik başlanmasını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, emmede azalma, uykuya eğilim ve vücut ısısında düşüklük nedeniyle acile getiriliyor. Son 12 saattir emmesinin belirgin azaldığı, daha az hareket ettiği ve bez sayısının düştüğü öğreniliyor. Anne doğumdan önce uzun süreli membran rüptürü olduğunu belirtmektedir.

Demografi: 10 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirmesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 58/34 mmHg | Nabız: 176/dk | Solunum: 62/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 35.8°C | Şok indeksi: 3.03 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve soluk görünümündedir.
- Periferik perfüzyon zayıf, kapiller dolum süresi 4 saniyedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Enflamatuvar süreci destekler. | Sonuç yorumu: Enflamatuvar süreci destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Enflamatuvar süreci destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 46 mg/L / <5 mg/L / Enflamatuvar süreci destekler.

Tetkik 2: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Sistemik hastalıkta eşlik edebilecek hipoglisemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Sistemik hastalıkta eşlik edebilecek hipoglisemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Sistemik hastalıkta eşlik edebilecek hipoglisemiyi gösterir. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / 42 mg/dL / 45-100 mg/dL yenidoğan için / Sistemik hastalıkta eşlik edebilecek hipoglisemiyi gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yenidoğanda kültürler alındıktan sonra ilk uygulanması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi

B) Oral beslenmenin artırılması ve eve gönderilmesi

C) Ateş olmadığı için enfeksiyon tedavisinin ertelenmesi

D) Fototerapi başlanması

E) Kan kültürü sonucuna göre antibiyotik kararını ertelemek

Doğru Cevap: Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi

A) Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi: Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi sepsis şüphesi olan yenidoğanda kültürler sonrası gecikmeden başlanması gereken uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.” ve “Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Oral beslenmenin artırılması ve eve gönderilmesi: Vakadaki Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır ve Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür. Bu olguda “Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.” ve “Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Ateş olmadığı için enfeksiyon tedavisinin ertelenmesi: Vakadaki Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır ve Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür. Bu olguda “Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.” ve “Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Fototerapi başlanması: Vakadaki Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır ve Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür. Bu olguda “Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.” ve “Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kan kültürü sonucuna göre antibiyotik kararını ertelemek: Vakadaki Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır ve Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür. Bu olguda “Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.” ve “Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda beslenme bozulması ve hipotermi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.” ve “Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.” birlikte okunduğunda Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi seçeneği öne çıkar; “Uzamış membran rüptürü öyküsü enfeksiyon riskini artırmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda sepsis ateş yerine hipotermi, emmede azalma, letarji, hipoperfüzyon ve hipoglisemi gibi nonspesifik bulgularla ortaya çıkabilir. Kültürler alındıktan sonra ampirik intravenöz antibiyotik ve dolaşım-glukoz desteği gecikmeden başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.”, “Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.” ve “Uzamış membran rüptürü öyküsü enfeksiyon riskini artırmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ampisilin ve gentamisin içeren intravenöz ampirik antibiyotik tedavisi ile destek tedavisi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Bebekte emmede azalma, letarji ve hipotermi vardır.

Kanıt 2: Kapiller dolum süresi uzamış ve kan basıncı düşüktür.

Kanıt 3: Uzamış membran rüptürü öyküsü enfeksiyon riskini artırmaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Yenidoğan sepsisinde ateş şart değildir; hipotermi ve beslenme bozulması da acil ampirik antibiyotik gerektirir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 162: v181-new-162-yenidoganda-kusma-ve-sok

Başlık: Yenidoğanda kusma ve şok

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Konjenital adrenal hiperplaziye bağlı tuz kaybettiren adrenal krizde ilk tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, tekrarlayan kusma, beslenememe ve halsizlik nedeniyle acile getiriliyor. Son iki gündür kusmalarının arttığı, emmesinin azaldığı ve kilo alamadığı öğreniliyor. Aile, dış genital görünümün doğumdan beri farklı olduğunu belirtmektedir.

Demografi: 18 günlük kız bebek | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 56/32 mmHg | Nabız: 182/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 3,25 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve dehidrate görünümündedir.
- Dış genital muayenede klitoromegali ve labial füzyon izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Tuz kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Tuz kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Tuz kaybını destekler. | Satırlar: Serum sodyum / 121 mmol/L / 135-145 mmol/L / Tuz kaybını destekler.

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum potasyum / 6.7 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Mineralokortikoid eksikliğini destekler.

Tetkik 3: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kortizol eksikliğine eşlik edebilir. | Sonuç yorumu: Kortizol eksikliğine eşlik edebilir. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kortizol eksikliğine eşlik edebilir. | Satırlar: Kan glukozu / 48 mg/dL / 70-140 mg/dL / Kortizol eksikliğine eşlik edebilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte ilk uygulanması gereken acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması
- B) Oral tuz desteğiyle ayaktan izlem planlamak
- C) Spironolakton başlanması
- D) Sıvı verilmeden insülin infüzyonu başlanması
- E) ACTH stimülasyon testi sonucunu bekleyip steroid tedavisini sonuca göre başlamak

Doğru Cevap: İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması

A) İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması: İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon adrenal krizde dolaşım, glukoz ve kortizol eksikliğini aynı anda hedefler. Vakadaki “Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Oral tuz desteğiyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır ve Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir. Bu olguda “Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Spironolakton başlanması: Vakadaki Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır ve Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir. Bu olguda “Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Sıvı verilmeden insülin infüzyonu başlanması: Sıvı ve steroid verilmeden insülin başlamak adrenal kriz tedavisini geciktirir ve hipoglisemi riskini artırır. Bu olguda “Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) ACTH stimülasyon testi sonucunu bekleyip steroid tedavisini sonuca göre başlamak: Vakadaki Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır ve Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir. Bu olguda “Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda kusma ve şok olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.” birlikte okunduğunda İzotonik sıvı,

dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması seçeneği öne çıkar; “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi adrenal krizle uyumludur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Virilizasyon, kusma, dehidratasyon, hipotansiyon, hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi tuz kaybettiren konjenital adrenal hiperplaziye bağlı adrenal krizi düşündürür. İlk tedavi izotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizondur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.”, “Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi adrenal krizle uyumludur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İzotonik sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon başlanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte dış genital virilizasyon bulguları vardır.

Kanıt 2: Hipotansiyon, taşikardi ve uzamış kapiller dolum şoku göstermektedir.

Kanıt 3: Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi adrenal krizle uyumludur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Tuz kaybettiren adrenal krizde sıvı, dekstroz ve stres doz hidrokortizon gecikmeden başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 163: v181-new-163-bobrek-hastasinda-kas-gucsuzlugu

Başlık: Böbrek hastasında kas güçsüzlüğü

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Hiperkalemi EKG değişikliği varsa ilk kardiyak membran stabilizasyon tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yaygın halsizlik, çarpıntı ve kas güçsüzlüğü nedeniyle acile getiriliyor. Kronik böbrek hastalığı nedeniyle takip edildiği, son günlerde diyetine uymadığı ve idrar miktarının azaldığı öğreniliyor.

Demografi: 13 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 138/86 mmHg | Nabız: 54/dk | Solunum: 20/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,39

Fizik Muayene

- Çocuk halsiz görünümündedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hayatı tehdit eden hiperkalemi mevcuttur. | Sonuç yorumu: Hayatı tehdit eden hiperkalemi mevcuttur. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Hayatı tehdit eden hiperkalemi mevcuttur. | Satırlar: Serum potasyum / 7.1 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L | Hayatı tehdit eden hiperkalemi mevcuttur.

Tetkik 2: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Klinik anlam: Kardiyak membran etkilenimini gösterir. | Sonuç yorumu: Kardiyak membran etkilenimini gösterir. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Yorum: Kardiyak membran etkilenimini gösterir. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. / / Kardiyak membran etkilenimini gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-089 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Klinik anlam: Kardiyak membran etkilenimini gösterir. | URL: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/089_089-hiperkalemi-sivri-t-qrs-genismesi-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/089_089-hiperkalemi-sivri-t-qrs-genismesi-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi
- B) Potasyum kısıtlı diyet önerilmesi
- C) Furosemid reçete edilip eve gönderilmesi
- D) İnsülin-glukoz ve beta-agonist tedavisini kardiyak membran stabilizasyonundan önce başlamak
- E) Potasyum replasmanı başlanması

Doğru Cevap: İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi

A) İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi: İntravenöz kalsiyum glukonat EKG değişikliği olan hiperkalemi de kardiyak membranı stabilize eden ilk tedavidir. Vakadaki “Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.” ve “Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Potasyum kısıtlı diyet önerilmesi: Vakadaki Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir ve Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır. Bu olguda “Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.” ve “Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Furosemid reçete edilip eve gönderilmesi: Furosemid bazı hastalarda potasyum atılımını artırabilir ancak EKG değişikliği olan acil hiperkalemi de ilk basamak değildir. Bu olguda “Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.” ve “Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) İnsülin-glukoz ve beta-agonist tedavisini kardiyak membran stabilizasyonundan önce başlamak: Vakadaki Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir ve Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır. Bu olguda “Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.” ve “Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Potasyum replasmanı başlanması: Vakadaki Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir ve Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır. Bu olguda “Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.” ve “Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Böbrek hastasında kas güçsüzlüğü olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.” ve “Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.” birlikte okunduğunda İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi seçeneği öne çıkar; “Kronik böbrek hastalığı ve oligüri hiperkalemi riskini artırmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Belirgin hiperkalemiye sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi eşlik ediyorsa öncelik miyokard membranını stabilize etmektir. İntravenöz kalsiyum glukonat serum potasyumunu düşürmez ancak ölümcül aritmileri önlemek için ilk verilmesi gereken tedavidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.”, “Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.” ve “Kronik böbrek hastalığı ve oligüri hiperkalemi riskini artırmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz kalsiyum glukonat verilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Serum potasyumu 7.1 mmol/L düzeyindedir.

Kanıt 2: Elektrokardiyografide sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.

Kanıt 3: Kronik böbrek hastalığı ve oligüri hiperkalemi riskini artırmaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Hiperkalemi EKG değişikliği varsa ilk adım intravenöz kalsiyumla kalbi stabilize etmektir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 164: v181-new-164-ilac-alimi-sonrasi-bilinc-degisikligi

Başlık: İlaç alımı sonrası bilinç değişikliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Trisiklik antidepresan zehirlenmesinde QRS genişlemesi varsa sodyum bikarbonat tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, evde çok sayıda antidepresan tablet aldıktan sonra bilinç bulanıklığı ve çarpıntı nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 2 saat önce aile bireyine ait amitriptilin tabletlerinden bilinmeyen miktarda aldığı öğreniliyor. Alımdan sonra uyku hali, ağız kuruluğu ve huzursuzluk gelişmiştir.

Demografi: 15 yaşında kız hasta | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/52 mmHg | Nabız: 146/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,66 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta ajite ve konfüzidir.
- Pupiller geniş, cilt kuru ve sıcaktır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sinüs taşikardisi ve QRS genişlemesi izlendi. | Klinik anlam: Sodyum kanal blokajını destekler. | Sonuç yorumu: Sodyum kanal blokajını destekler. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Sinüs taşikardisi ve QRS genişlemesi izlendi. | Yorum: Sodyum kanal blokajını destekler. | Satırlar: Elektrokardiyografi / QRS 132 ms / <100 ms / Sodyum kanal blokajını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-090 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Sinüs taşikardisi ve QRS genişlemesi izlendi. | Klinik anlam: Sodyum kanal blokajını destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/090_090-sodyum-kanal-blokaji-qrs-genislemesi-ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/090_090-sodyum-kanal-blokaji-qrs-genislemesi-ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Sinüs taşikardisi ve QRS genişlemesi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun spesifik acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi
B) Flumazenil verilmesi
C) Nalokson verilmesi
D) Beta bloker verilmesi
E) Oral aktif kömür sonrası ayaktan izlem planlamak

Doğru Cevap: İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi

A) İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi: İntravenöz sodyum bikarbonat trisiklik antidepresan toksisitesinde QRS genişlemesi ve kardiyak sodyum kanal blokajını hedefler. Vakadaki "Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir." ve "Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Flumazenil verilmesi: Flumazenil benzodiazepin antagonisti olup trisiklik antidepresan kaynaklı QRS genişlemesini düzeltmez. Bu olguda "Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir." ve "Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nalokson verilmesi: Nalokson opioid toksisitesinde solunum depresyonunu geri çevirir; antikolinerjik ve kardiyotoksik tabloya uygun değildir. Bu olguda "Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir." ve "Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Beta bloker verilmesi: Beta bloker taşikardiye azaltabilir gibi görünse de iletim bozukluğu ve hipotansiyon olan trisiklik antidepresan toksisitesinde uygun spesifik tedavi değildir. Bu olguda "Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir." ve "Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oral aktif kömür sonrası ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir ve Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler. Bu olguda "Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir." ve "Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: İlaç alımı sonrası bilinç değişikliği olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir." ve "Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler." birlikte okunduğunda İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi seçeneği öne çıkar; "Elektrokardiyografide QRS genişlemesi sodyum kanal blokajını göstermektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Amitriptilin alımı sonrası antikolinerjik bulgular, hipotansiyon, taşikardi ve QRS genişlemesi trisiklik antidepresan toksisitesini düşündürür. Geniş QRS sodyum kanal blokajını gösterir ve intravenöz sodyum bikarbonat kardiyak toksisiteyi azaltır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir.", "Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler." ve "Elektrokardiyografide QRS genişlemesi sodyum kanal blokajını göstermektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz sodyum bikarbonat verilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastanın amitriptilin aldığı öğrenilmiştir.

Kanıt 2: Ağız kuruluğu, midriyazis, kuru sıcak cilt ve konfüzyon antikolinerjik toksisiteyi destekler.

Kanıt 3: Elektrokardiyografide QRS genişlemesi sodyum kanal blokajını göstermektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Trisiklik antidepresan zehirlenmesinde geniş QRS varsa tedavi intravenöz sodyum bikarbonattır.
Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 165: v181-new-165-kulak-cinlamasi-ve-hiperventilasyon

Başlık: Kulak çınlaması ve hiperventilasyon

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Salisilat zehirlenmesinde asit-baz paternini ve idrar alkalinizasyon tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, çok sayıda ağrı kesici aldıktan sonra bulantı, kulak çınlaması ve hızlı soluma nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 6 saat önce yüksek doz asetilsalisilik asit aldığı öğreniliyor. Sonrasında kusma, terleme, kulak çınlaması ve huzursuzluk gelişmiştir.

Demografi: 16 yaşında erkek hasta | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/68 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 34/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 38.2°C | Şok indeksi: 1,14 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta ajite ve terlidir.
- Derin hızlı solunum paterni vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Karışık asit-baz bozukluğu saptandı. | Klinik anlam: Solunumsal alkaloz ve metabolik asidoz birlikteliğini destekler. | Sonuç yorumu: Solunumsal alkaloz ve metabolik asidoz birlikteliğini destekler. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Karışık asit-baz bozukluğu saptandı. | Yorum: Solunumsal alkaloz ve metabolik asidoz birlikteliğini destekler. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.47, PaCO₂ 23, HCO₃ 16 mmHg ve mmol/L / pH 7.35-7.45, PaCO₂ 35-45 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/L / Solunumsal alkaloz ve metabolik asidoz birlikteliğini destekler.

Tetkik 2: Serum salisilat düzeyi

Etiket: Serum salisilat düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Klinik anlam: Salisilat toksisitesini destekler. | Sonuç yorumu: Salisilat toksisitesini destekler. | Sonuç başlığı: Serum salisilat düzeyi | Sonuç özeti: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Yorum: Salisilat toksisitesini destekler. | Satırlar: Serum salisilat düzeyi / 58 mg/dL / Terapötik aralık genellikle 10-30 mg/dL / Salisilat toksisitesini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu
B) Solunumu baskılamak için sedatif verilmesi
C) Nalokson verilmesi
D) Oral sıvı desteğiyle ayakta izlem planlamak
E) İnsülin ve potasyum tedavisi başlanması

Doğru Cevap: İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu

- A) İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu: İntravenöz sodyum bikarbonat serum ve idrar alkalinizasyonu sağlayarak salisilat toksisitesinde eliminasyonu artırır. Vakadaki "Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır." ve "Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Solunumu baskılamak için sedatif verilmesi: Solunumu sedatifle baskılamak salisilatın kompensatuvar hiperventilasyonunu bozarak asidemiyi ağırlaştırabilir. Bu olguda "Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır." ve "Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nalokson verilmesi: Nalokson opioid toksisitesinde kullanılır; salisilatın asit-baz ve eliminasyon sorununu düzeltmez. Bu olguda "Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır." ve "Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Oral sıvı desteğiyle ayakta izlem planlamak: Vakadaki Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır ve Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler. Bu olguda "Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır." ve "Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) İnsülin ve potasyum tedavisi başlanması: İnsülin ve potasyum hiperkalemi tedavisinde kullanılır; salisilat toksisitesinin temel tedavisi değildir. Bu olguda "Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır." ve "Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kulak çınlaması ve hiperventilasyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır." ve "Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler." birlikte okunduğunda İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu seçeneği öne çıkar; "Kan gazında düşük PaCO₂ ve düşük bikarbonat birlikte saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Salisilat toksisitesinde erken solunum merkezi uyarılması solunumsal alkaloz yapar, ilerleyen dönemde metabolik asidoz eklenir. İntravenöz sodyum bikarbonatla serum ve idrar alkalinizasyonu salisilatın renal atılımını artırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır.", "Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler." ve "Kan gazında düşük PaCO₂ ve düşük bikarbonat birlikte saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz sodyum bikarbonat ile serum ve idrar alkalinizasyonu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta yüksek doz asetilsalisilik asit almıştır.

Kanıt 2: Kulak çınlaması, kusma ve hiperventilasyon salisilat toksisitesini destekler.

Kanıt 3: Kan gazında düşük PaCO₂ ve düşük bikarbonat birlikte saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Salisilat zehirlenmesinde solunumsal alkaloz ve metabolik asidoz birlikte görülebilir; tedavide alkalinizasyon önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 166: v181-new-166-ani-baslayan-skrotal-agri

Başlık: Ani başlayan skrotal ağrı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Testis torsiyonunda zaman kritik acil cerrahi yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan sağ testis ağrısı ve bulantı nedeniyle acile başvuruyor. Ağrının 2 saat önce istirahatte aniden başladığını, giderek şiddetlendiğini ve bulantının eşlik ettiğini belirtiyor. Travma, dizüri veya ateş tariflemiyor.

Demografi: 14 yaşında erkek hasta | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,04 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ hemiskrotum şiş ve hassastır.
- Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.
- Kremaster refleksi sağda alınamaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması
B) Oral antibiyotik başlanıp 48 saat sonra kontrol
C) Doppler ultrasonografi randevusu sonrasında elektif ürolojik girişim planlamak
D) Elektif infertilite değerlendirmesi yapılması
E) İdrar kültürü sonucuna göre tedavi planlanması

Doğru Cevap: Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması

- A) Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması: Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon testis torsiyonunda testis canlılığını korumak için doğru acil yaklaşımdır. Vakadaki “Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.” ve “Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Oral antibiyotik başlanıp 48 saat sonra kontrol: Oral antibiyotik epididimite düşünülebilir ancak ani torsiyon bulguları olan hastada cerrahiye geciktirir. Bu olguda “Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.” ve “Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Doppler ultrasonografi randevusu sonrasında elektif ürolojik girişim planlamak: Vakadaki Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir ve Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır. Bu olguda “Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.” ve “Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Elektif infertilite değerlendirmesi yapılması: Vakadaki Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir ve Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır. Bu olguda “Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.” ve “Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) İdrar kültürü sonucuna göre tedavi planlanması: Vakadaki Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir ve Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır. Bu olguda “Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.” ve “Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani başlayan skrotal ağrı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.” ve “Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.” birlikte okunduğunda Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması seçeneği öne çıkar; “Sağ kremaster refleksi alınamamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ani başlayan şiddetli testis ağrısı, bulantı, yüksek yerleşimli transvers testis ve kremaster refleksinin kaybı testis torsiyonunu düşündürür. Testis canlılığı zamanla hızla azaldığından acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.”, “Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.” ve “Sağ kremaster refleksi alınamamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil ürolojik eksplorasyon ve detorsiyon planlanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ağrı istirahatte aniden başlamış ve şiddetlenmiştir.

Kanıt 2: Sağ testis yüksek yerleşimli ve transvers pozisyonundadır.

Kanıt 3: Sağ kremaster refleksi alınamamaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Testis torsiyonu klinik şüphe zaman kritik cerrahi acildir; gecikme testis kaybına yol açabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 167: v181-new-167-fiskirir-tarzda-kusma

Başlık: Fıskırır tarzda kusma

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Hipertrofik pilor stenozunda klinik ve elektrolit bulgularıyla tedavi önceliğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme sonrası fıskırır tarzda kusma ve kilo alamama nedeniyle acile getiriliyor. Son 10 gündür her beslenmeden sonra safrasız, fıskırır tarzda kusma olduğu öğreniliyor. Kusmadan sonra yeniden acıktığı, bez sayısının azaldığı ve kilo alımının yetersiz olduğu belirtiliyor.

Demografi: 5 haftalık erkek bebek | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 76/44 mmHg | Nabız: 154/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,03 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek dehidrate görünümündedir.
- Üst abdomen muayenesinde zeytin benzeri küçük sert kitle palpe edilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum klor

Etiket: Serum klor | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kusmaya bağlı klor kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Kusmaya bağlı klor kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Serum klor | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kusmaya bağlı klor kaybını destekler. | Satırlar: Serum klor / 88 mmol/L / 98-106 mmol/L / Kusmaya bağlı klor kaybını destekler.

Tetkik 2: Venöz kan gazı

Etiket: Venöz kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik alkaloz saptandı. | Klinik anlam: Hipokloremik metabolik alkalozla uyumludur. | Sonuç yorumu: Hipokloremik metabolik alkalozla uyumludur. | Sonuç başlığı: Venöz kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik alkaloz saptandı. | Yorum: Hipokloremik metabolik alkalozla uyumludur. | Satırlar: Venöz kan gazı / pH 7.51, HCO₃ 34 mmol/L / pH 7.35-7.45, HCO₃ 22-26 mmol/L / Hipokloremik metabolik alkalozla uyumludur.

Tetkik 3: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğu artmış saptandı. | Klinik anlam: Hipertrofik pilor stenozunu destekler. | Sonuç yorumu: Hipertrofik pilor stenozunu destekler. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğu artmış saptandı. | Yorum: Hipertrofik pilor stenozunu destekler. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğu artmış saptandı. // Hipertrofik pilor stenozunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-091 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğu artmış saptandı. | Klinik anlam: Hipertrofik pilor stenozunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/091_091-hipertrofik-pilor-stenozu-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/091_091-hipertrofik-pilor-stenozu-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğu artmış saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte cerrahi öncesi ilk yapılması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi
- B) Acil piloromiyotomiye sıvı verilmeden başlanması
- C) Oral beslenmenin artırılması
- D) Antibiyotik tedavisiyle ayaktan izlem planlamak
- E) Metabolik alkaloz ve hipokalemi düzeltilmeden cerrahiye hazırlık yapmak

Doğru Cevap: Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi

- A) Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi: Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi piloromiyotomi öncesi güvenli anestezi ve stabilizasyon için ilk adımdır. Vakadaki “Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.” ve “Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Acil piloromiyotomiye sıvı verilmeden başlanması: Sıvı verilmeden acil cerrahiye başlamak dehidratasyon ve metabolik alkaloz nedeniyle risklidir. Bu olguda “Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.” ve “Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Oral beslenmenin artırılması: Vakadaki Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır ve Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir. Bu olguda “Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.” ve “Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Antibiyotik tedavisiyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır ve Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir. Bu olguda “Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.” ve “Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Metabolik alkaloz ve hipokalemi düzeltilmeden cerrahiye hazırlık yapmak: Vakadaki Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır ve Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir. Bu olguda “Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.” ve “Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Fıskırır tarzda kusma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.” ve “Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.” birlikte okunduğunda Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi seçeneği öne çıkar; “Hipokloremik metabolik alkaloz ve ultrasonografik pilor kalınlaşması vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Safrasız fıskırır kusma, kusma sonrası açlık, zeytin benzeri kitle, ultrason bulguları ve hipokloremik metabolik alkaloz hipertrofik pilor stenozunu gösterir. Kesin tedavi piloromiyotomi olsa da önce dehidratasyon ve elektrolit-asit baz bozukluğu düzeltilmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.”, “Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.” ve “Hipokloremik metabolik alkaloz ve ultrasonografik pilor kalınlaşması vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Sıvı-elektrolit bozukluğunun düzeltilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kusma safrasız ve fıskırır tarzda beslenme sonrası olmaktadır.

Kanıt 2: Muayenede zeytin benzeri epigastrik kitle palpe edilmiştir.

Kanıt 3: Hipokloremik metabolik alkaloz ve ultrasonografik pilor kalınlaşması vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Pilor stenozunda cerrahi kesin tedavidir ancak önce sıvı ve elektrolit bozuklukları düzeltilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 168: v181-new-168-anestezi-sirasinda-ani-hipertermi

Başlık: Anestezi sırasında ani hipertermi

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Malign hipertermide tetikleyici ajan ve dantrolen tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, genel anestezi sırasında hızla yükselen vücut sıcaklığı, kas rijiditesi ve taşikardi gelişmesi nedeniyle değerlendiriliyor. Elektif cerrahi için inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanıldığı öğreniliyor. Ailede anestezi sırasında açıklanamayan ölüm öyküsü olduğu sonradan belirtiliyor.

Demografi: 7 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 178/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 40.5°C | Şok indeksi: 1,89 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk entübe halde takip edilmektedir.
- Yaygın kas rijiditesi ve çene sertliği vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik ve respiratuvar asidoz saptandı. | Klinik anlam: Hipermetabolik krizi destekler. | Sonuç yorumu: Hipermetabolik krizi destekler. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik ve respiratuvar asidoz saptandı. | Yorum: Hipermetabolik krizi destekler. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.12, PaCO₂ 68, HCO₃ 19 mmHg ve mmol/L / pH 7.35-7.45, PaCO₂ 35-45 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/L / Hipermetabolik krizi destekler.

Tetkik 2: Serum kreatin kinaz

Etiket: Serum kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kas yıkımını destekler. | Sonuç yorumu: Kas yıkımını destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatin kinaz | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Kas yıkımını destekler. | Satırlar: Serum kreatin kinaz / 12600 U/L / 30-200 U/L / Kas yıkımını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun spesifik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi
- B) Asetaminofen verilerek ameliyata devam edilmesi
- C) Süksinilkolin dozunun artırılması
- D) Nalokson verilmesi
- E) Flumazenil verilmesi

Doğru Cevap: Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi

A) Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi: Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi malign hipertermiye spesifik ve hayat kurtarıcı tedavidir. Vakadaki "Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır." ve "Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Asetaminofen verilerek ameliyata devam edilmesi: Asetaminofen hipotalamik ateşte kullanılabilir ancak malign hipertermide kas kaynaklı hipermetabolizmayı durdurmaz. Bu olguda "Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır." ve "Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Süksinilkolin dozunun artırılması: Vakadaki Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır ve Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır. Bu olguda "Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır." ve "Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nalokson verilmesi: Nalokson opioid toksisitesinde kullanılır; ryanodin reseptörü aracılı kalsiyum salınımını düzeltmez. Bu olguda "Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır." ve "Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Flumazenil verilmesi: Flumazenil benzodiazepin antagonisti olarak etki eder; malign hipertermi tedavisinde yeri yoktur. Bu olguda "Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır." ve "Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Anestezi sırasında ani hipertermi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır." ve "Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır." birlikte okunduğunda Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi seçeneği öne çıkar; "Asidoz ve kreatin kinaz yüksekliği hipermetabolik kas krizini destekler." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin sonrası ani hipertermi, kas rijiditesi, end-tidal karbondioksit artışı, asidoz ve kreatin kinaz yüksekliği malign hipertermiyi düşündürür. Spesifik tedavi dantrolendir; tetikleyici ajanlar kesilmeli ve aktif soğutma-destek tedavisi uygulanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır.", "Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır." ve "Asidoz ve kreatin kinaz yüksekliği hipermetabolik kas krizini destekler." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Dantrolen verilmesi ve tetikleyici anesteziğin kesilmesi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Tablo inhalasyon anestezisi ve süksinilkolin kullanımı sırasında başlamıştır.

Kanıt 2: Hipertermi, kas rijiditesi ve end-tidal karbondioksit artışı vardır.

Kanıt 3: Asidoz ve kreatin kinaz yüksekliği hipermetabolik kas krizini destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Malign hipertermide spesifik tedavi dantrolendir; tetikleyici ajanlar hemen kesilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 169: v181-new-169-su-alimi-sonrasi-nobet

Başlık: Su alımı sonrası nöbet

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Semptomatik hiponatremide nöbet varsa hipertonic salin tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, kusma ve baş ağrısını takiben gelişen jeneralize nöbet nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi çocuğun gastroenterit nedeniyle gün boyunca çok miktarda sadece su içtiğini, tuzlu gıda ve oral rehidratasyon solüsyonu almadığını belirtiyor. Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 102/64 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,10 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk nöbet sonrası somnolandır.
- Hafif periorbital ödem vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Semptomatik ağır hiponatremiyi destekler. | Sonuç yorumu: Semptomatik ağır hiponatremiyi destekler. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Semptomatik ağır hiponatremiyi destekler. | Satırlar: Serum sodyum / 118 mmol/L / 135-145 mmol/L / Semptomatik ağır hiponatremiyi destekler.

Tetkik 2: Kapiller kan glukozu

Etiket: Kapiller kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır. | Sonuç yorumu: Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır. | Sonuç başlığı: Kapiller kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır. | Satırlar: Kapiller kan glukozu / 94 mg/dL / 70-140 mg/dL / Hipoglisemi nöbet nedeni olarak geri plandadır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipertonik salin bolusu verilmesi
B) Serbest su verilmesine devam edilmesi
C) Oral su alımının artırılması
D) Sodyum düzeltilmeden idame antiepileptik başlanması
E) Furosemid verilerek ayaktan izlem planlamak

Doğru Cevap: Hipertonik salin bolusu verilmesi

- A) Hipertonik salin bolusu verilmesi: Hipertonik salin bolusu semptomatik ağır hiponatremide serebral ödemi azaltmak için uygun ilk tedavidir. Vakadaki “Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.” ve “Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Serbest su verilmesine devam edilmesi: Vakadaki Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır ve Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir. Bu olguda “Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.” ve “Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin bolusu verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Oral su alımının artırılması: Vakadaki Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır ve Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir. Bu olguda “Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.” ve “Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin bolusu verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Sodyum düzeltilmeden idame antiepileptik başlanması: Vakadaki Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır ve Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir. Bu olguda “Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.” ve “Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin bolusu verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Furosemid verilerek ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır ve Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir. Bu olguda “Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.” ve “Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin bolusu verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Su alımı sonrası nöbet olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.” ve “Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Hipertonik salin bolusu verilmesi seçeneği öne çıkar; “Serum sodyumu 118 mmol/L olarak belirgin düşüktür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nöbet ve somnolansla seyreden 118 mmol/L sodyum düzeyi semptomatik ağır hiponatremidir. Akut nörolojik bulgu varlığında ilk amaç serebral ödemi azaltmak için kontrollü hipertonik salin bolusu ile sodyumu güvenli şekilde yükseltmektir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.”, “Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.” ve “Serum sodyumu 118 mmol/L olarak belirgin düşüktür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hipertonik salin bolusu verilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuk gün boyunca elektrolitsiz fazla su almıştır.

Kanıt 2: Nöbet öncesi baş ağrısı ve dalgınlık gelişmiştir.

Kanıt 3: Serum sodyumu 118 mmol/L olarak belirgin düşüktür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Hiponatremiye bağlı nöbet acildir; ilk tedavi hipertonic salindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 170: v181-new-170-sag-alt-kadran-agrisi

Başlık: Sağ alt kadran ağrısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Çocukta akut apandisitte klinik bulgularla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, karın ağrısı, iştahsızlık ve kusma nedeniyle acile getiriliyor. Ağrının önce göbek çevresinde başladığı, sonrasında sağ alt kadrana yerleştiği öğreniliyor. Son 12 saatte iştahsızlık ve bir kez kusma gelişmiştir. İshal belirgin değildir.

Demografi: 10 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 38.1°C | Şok indeksi: 1,12 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ alt kadranda hassasiyet, rebound ve istemli defans vardır.
- Yürürken ağrısının arttığı gözlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut inflamasyonu destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 16400 /mm³ / 5000-15000 /mm³ / Akut inflamasyonu destekler.

Tetkik 2: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Kompresyona gelmeyen, çapı artmış apendiks ve çevresel yağlı doku inflamasyonu izlendi. | Klinik anlam: Akut apandisit lehinedir. | Sonuç yorumu: Akut apandisit lehinedir. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Kompresyona gelmeyen, çapı artmış apendiks ve çevresel yağlı doku inflamasyonu izlendi. | Yorum: Akut apandisit lehinedir. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / 8.5 mm / <6 mm / Akut apandisit lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-092 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Kompresyona gelmeyen, çapı artmış apendiks ve çevresel yağlı doku inflamasyonu izlendi. | Klinik anlam: Akut apandisit lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/092_092-akut-apandisit-abdominal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/092_092-akut-apandisit-abdominal-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Kompresyona gelmeyen, çapı artmış apendiks ve çevresel yağlı doku inflamasyonu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut apandisit
B) Viral gastroenterit
C) İnvajinasyon
D) Hipertrofik pilor stenozu
E) İrritabl bağırsak sendromu

Doğru Cevap: Akut apandisit

- A) Akut apandisit: Akut apandisit göç eden ağrı, sağ alt kadran periton bulguları, lökositoz ve ultrasonografik apendiks bulgularıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Viral gastroenterit: Viral gastroenteritte yaygın kramp, ishal ve genellikle belirgin lokal periton bulgusu olmaması beklenir. Bu olguda “Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) İnvajinasyon: İnvajinasyon daha küçük çocukta aralıklı kolik ağrı, bacakları karna çekme ve kırmızı jöle dışkıyla düşünülür. Bu olguda “Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Hipertrofik pilor stenozu: Hipertrofik pilor stenozu küçük bebekte safrsız fışkır kusma ve metabolik alkalozla seyreder; 10 yaş tablosuna uymaz. Bu olguda “Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) İrritabl bağırsak sendromu: İrritabl bağırsak sendromu kronik fonksiyonel yakınmalarla ilişkilidir; ateş, lökositoz ve periton bulgularını açıklamaz. Bu olguda “Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut apandisit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sağ alt kadran ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.” ve “Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.” birlikte okunduğunda Akut apandisit seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide genişlemiş, kompresyona gelmeyen apendiks izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana lokalize olan ağrı, iştahsızlık, kusma, düşük dereceli ateş, lökositoz ve ultrasonografide geniş-kompresyona gelmeyen apendiks akut apandisiti düşündürür. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.”, “Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.” ve “Ultrasonografide genişlemiş, kompresyona gelmeyen apendiks izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut apandisit en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Ağrı periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleşmiştir.

Kanıt 2: Sağ alt kadranda rebound ve defans vardır.

Kanıt 3: Ultrasonografide genişlemiş, kompresyona gelmeyen apendiks izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Çocukta göbek çevresinden sağ alt kadrana göç eden ağrı akut apandisit için klasik ipucudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 171: v182-new-171-travma-sonrasi-ani-solunum-bozulmasi

Başlık: Travma sonrası ani solunum bozulması

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Gerilim pnömotoraksında klinik bulgularla acil dekompresyon gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, göğüs travması sonrası hızla artan nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle travma odasına alınıyor. Bisikletle araç çarpışması sonrası sağ hemitoraksa darbe aldığı öğreniliyor. Olay yerinde başlangıçta konuşabildiği ancak acile gelirken solunum sıkıntısının hızla arttığı belirtiliyor.

Demografi: 13 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 72/44 mmHg | Nabız: 162/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %82% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,25 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk ajite ve siyanoze görünümündedir.
- Sağ hemitoraksta solunum sesleri belirgin azalmış, perküsyon hipersonordur.
- Trakea sola deviye görünür.
- Boyun venleri belirgindir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi
B) Akciğer grafisi çekilene kadar tüm girişimlerin ertelenmesi
C) Portable akciğer grafisi çekilene kadar dekompresyon kararını ertelemek
D) Oral antibiyotik başlanarak ayaktan izlem planlamak
E) Bronkodilatör verilerek astım atağı gibi izlenmesi

Doğru Cevap: Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi

A) Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi: Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü, dolaşımı bozan gerilim pnömotoraksında hayat kurtarıcı ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Akciğer grafisi çekilene kadar tüm girişimlerin ertelenmesi: Grafi beklemek hemodinamik instabil gerilim pnömotoraksında tedaviyi geciktirerek kardiyak arreste yol açabilir. Bu olguda “Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Portable akciğer grafisi çekilene kadar dekompresyon kararını ertelemek: Vakadaki Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir ve Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur. Bu olguda “Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral antibiyotik başlanarak ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir ve Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur. Bu olguda “Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Bronkodilatör verilerek astım atağı gibi izlenmesi: Bronkodilatör astım bronkospazmını hedefler; trakeal deviasyon ve tek taraflı hipersonoriteyi açıklayan pnömotoraksı çözmez. Bu olguda “Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Travma sonrası ani solunum bozulması olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.” birlikte okunduğunda Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi seçeneği öne çıkar; “Trakeal deviasyon, hipotansiyon ve hipoksemi dolaşımı bozan gerilim fizyolojisini destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Travma sonrası tek taraflı solunum sesi kaybı, hipersonorite, trakeal deviasyon, boyun ven dolgunluğu, hipotansiyon ve hipoksemi gerilim pnömotoraksı düşündürür. Bu tablo klinik tanıdır ve görüntüleme beklenmeden acil iğne dekompresyonu yapılmalı, ardından toraks tüpü ile kalıcı drenaj sağlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.”, “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.” ve “Trakeal deviasyon, hipotansiyon ve hipoksemi dolaşımı bozan gerilim fizyolojisini destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil iğne dekompresyonu ve ardından toraks tüpü yerleştirilmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocukta künt göğüs travması sonrası ani solunum bozulması gelişmiştir.

Kanıt 2: Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve perküsyon hipersonordur.

Kanıt 3: Trakeal deviasyon, hipotansiyon ve hipoksemi dolaşımı bozan gerilim fizyolojisini destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Gerilim pnömotoraksında tanı kliniklidir; grafi beklenmeden acil dekompresyon yapılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 172: v182-new-172-pestisid-temasi-sonrasi-sekresyon-artisi

Başlık: Pestisid teması sonrası sekresyon artışı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Organofosfat zehirlenmesinde kolinerjik bulgularla antidot tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, tarım ilacı bulunan depoda oynadıktan sonra kusma, salya artışı ve solunum sıkıntısı nedeniyle getiriliyor. Yaklaşık bir saat önce pestisid kokusunun yoğun olduğu kapalı alanda bulunduğu ve ellerine sıvı bulaştığı öğreniliyor. Sonrasında karın krampları, kusma, göz yaşarması ve hırıltılı solunum başlamıştır.

Demografi: 5 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/48 mmHg | Nabız: 58/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %88% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,67

Fizik Muayene

- Çocuk terli ve huzursuzdur.
- Belirgin salivasyon, bronkore, miyozis ve bilateral hışıltı vardır.
- Kaslarda fasikülasyonlar izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma kolinesteraz aktivitesi

Etiket: Plazma kolinesteraz aktivitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Organofosfat maruziyetini destekler. | Sonuç yorumu: Organofosfat maruziyetini destekler. | Sonuç başlığı: Plazma kolinesteraz aktivitesi | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Organofosfat maruziyetini destekler. | Satırlar: Plazma kolinesteraz aktivitesi / Düşük saptandı. // Organofosfat maruziyetini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun spesifik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Atropin ve pralidoksim verilmesi
B) Nalokson verilmesi
C) Flumazenil verilmesi
D) N-asetilsistein verilmesi
E) Oral antihistaminik verilmesi

Doğru Cevap: Atropin ve pralidoksim verilmesi

- A) Atropin ve pralidoksim verilmesi: Atropin ve pralidoksim organofosfat zehirlenmesinde muskarinik ve nikotinik etkileri hedefleyen uygun spesifik tedavidir. Vakadaki “Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.” ve “Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Nalokson verilmesi: Nalokson opioid toksitesinde kullanılır; kolinerjik sekresyon artışı ve fasikülasyonları düzeltmez. Bu olguda “Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.” ve “Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Flumazenil verilmesi: Flumazenil benzodiazepin etkisini antagonize eder; asetilkolinesteraz inhibisyonunu tedavi etmez. Bu olguda “Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.” ve “Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) N-asetilsistein verilmesi: N-asetilsistein parasetamol toksitesinde kullanılır; organofosfat zehirlenmesinin antidotu değildir. Bu olguda “Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.” ve “Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Oral antihistaminik verilmesi: Vakadaki Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır ve Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur. Bu olguda “Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.” ve “Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Pestisid teması sonrası sekresyon artışı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.” ve “Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.” birlikte okunduğunda Atropin ve pralidoksim verilmesi seçeneği öne çıkar; “Fasikülasyonlar nikotinik reseptör etkilenimini destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Pestisid maruziyeti sonrası salivasyon, lakrimasyon, bronkore, miyozis, bradikardi, kusma ve fasikülasyonlar organofosfat zehirlenmesini düşündürür. Atropin muskarinik etkileri geri çevirir; pralidoksim asetilkolinesterazı yeniden aktive ederek nikotinik bulgulara da katkı sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.”, “Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.” ve “Fasikülasyonlar nikotinik reseptör etkilenimini destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Atropin ve pralidoksim verilmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk pestisid içeren kapalı alanda maruz kalmıştır.

Kanıt 2: Miyozis, salivasyon, bronkore, bradikardi ve kusma kolinerjik toksidromla uyumludur.

Kanıt 3: Fasikülasyonlar nikotinik reseptör etkilenimini destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Organofosfat zehirlenmesinde atropin sekresyon ve bronkoreyi, pralidoksim enzim inhibisyonunu hedefler.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 173: v182-new-173-temizlik-maddesi-icme-sonrasi-agiz-yanigi

Başlık: Temizlik maddesi içme sonrası ağız yanığı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Kostik madde alımında uygun ilk yaklaşımı ve yapılmaması gerekenleri ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, lavabo açıcı içtiği fark edildikten sonra ağızda yanma ve salya akması nedeniyle acile getiriliyor. Ailesi çocuğun az miktarda alkali temizlik maddesini ağzına aldığını, sonrasında ağlama, ağızda yanma ve yutkunmada zorlanma geliştiğini belirtiyor. Evde kusturulmamıştır.

Demografi: 3 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,18 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk huzursuzdur.
- Dudak ve oral mukozada eritemli yanık alanları vardır.
- Salya akışı artmıştır ancak solunum sıkıntısı yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun ilk yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek
- B) Çocuğu kusturarak maddenin çıkarılmasını sağlamak
- C) Asidi bazla nötralize etmek için ev tipi karşı madde içirmek
- D) Aktif kömür vererek tüm kostik maddeyi bağlamak
- E) Semptomlara rağmen ayaktan izlem planlamak

Doğru Cevap: Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek

A) Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek: Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimini izlemek semptomatik kostik alımda doğru ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.” ve “Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Çocuğu kusturarak maddenin çıkarılmasını sağlamak: Vakadaki Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır ve Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır. Bu olguda “Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.” ve “Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Asidi bazla nötralize etmek için ev tipi karşı madde içirmek: Vakadaki Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır ve Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır. Bu olguda “Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.” ve “Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Aktif kömür vererek tüm kostik maddeyi bağlamak: Aktif kömür kostik maddeleri etkili biçimde bağlamaz ve endoskopik değerlendirmeyi zorlaştırabilir. Bu olguda “Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.” ve “Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Semptomlara rağmen ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır ve Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır. Bu olguda “Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.” ve “Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Temizlik maddesi içme sonrası ağız yanığı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.” ve “Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.” birlikte okunduğunda Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek seçeneği öne çıkar; “Yutkunma güçlüğü özofageal etkilenim riskini düşündürmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kostik madde alımında öncelik hava yolu, solunum ve dolaşım değerlendirmesi, ağızdan alımın kesilmesi ve semptom varlığında endoskopik değerlendirme planıdır. Kusturma veya nötralizasyon ısı açığa çıkarak ve tekrar temas oluşturarak özofagus hasarını artırabilir; aktif kömür kostik maddelerde etkili değildir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.”, “Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.” ve “Yutkunma güçlüğü özofageal etkilenim riskini düşündürmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ağızdan alımı kesmek, hava yolunu değerlendirmek ve endoskopi gereksinimi için izlemek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuk alkali temizlik maddesi almıştır.

Kanıt 2: Oral mukozada yanık ve salya akışı vardır.

Kanıt 3: Yutkunma güçlüğü özofageal etkilenim riskini düşündürmektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Kostik alımda kusturma ve nötralizasyon yapılmaz; hava yolu ve endoskopi gereksinimi değerlendirilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 174: v182-new-174-gaz-yagi-icme-sonrasi-oksukuruk

Başlık: Gaz yağı içme sonrası öksürük

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Hidrokarbon aspirasyonunda solunum bulguları varsa destek tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, gaz yağı içtiği fark edildikten sonra öksürük ve hırıltı nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun pet şişede saklanan az miktarda gaz yağını içtiğini, hemen ardından öksürük nöbeti ve kusma geliştiğini belirtiyor. Evde kusturma denenmemiştir.

Demografi: 2 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 38/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 37.1°C | Şok indeksi: 1,56 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk takipneiktir.
- Bilateral hışıltı ve sağ bazalde ince raller duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ alt zonda hafif infiltratif görünüm izlendi. | Klinik anlam: Aspirasyon pnömonitisini destekler. | Sonuç yorumu: Aspirasyon pnömonitisini destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Sağ alt zonda hafif infiltratif görünüm izlendi. | Yorum: Aspirasyon pnömonitisini destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Sağ alt zonda hafif infiltratif görünüm izlendi. / / Aspirasyon pnömonitisini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-093 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ alt zonda hafif infiltratif görünüm izlendi. | Klinik anlam: Aspirasyon pnömonitisini destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/093_093-aspirasyon-pnmonitisini-sag-alt-zon-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/093_093-aspirasyon-pnmonitisini-sag-alt-zon-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Sağ alt zonda hafif infiltratif görünüm izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun başlangıç yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma
- B) Zorla kusturma
- C) Rutin gastrik lavaj yapılması
- D) Aktif kömür verilmesi
- E) Kusturma ve gastrik lavaj sonrası profilaktik antibiyotik başlamak

Doğru Cevap: Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma

- A) Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma: Oksijen ve solunum desteğiyle izlem, aspirasyon bulguları olan hidrokarbon alımında uygun başlangıç yaklaşımıdır. Vakadaki “Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.” ve “Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Zorla kusturma: Vakadaki Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır ve Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır. Bu olguda “Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.” ve “Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Rutin gastrik lavaj yapılması: Rutin gastrik lavaj aspirasyon riskini artırdığı için hidrokarbon alımında genellikle uygun değildir. Bu olguda “Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.” ve “Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Aktif kömür verilmesi: Vakadaki Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır ve Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır. Bu olguda “Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.” ve “Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Kusturma ve gastrik lavaj sonrası profilaktik antibiyotik başlamak: Vakadaki Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır ve Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır. Bu olguda “Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.” ve “Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gaz yağı içme sonrası öksürük olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.” ve “Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.” birlikte okunduğunda Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma seçeneği öne çıkar; “Akciğer grafisinde aspirasyonla uyumlu infiltratif görünüm izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hidrokarbon alımında ana risk aspirasyon pnömonitisidir. Öksürük, hışıltı, hipoksemi ve infiltrasyon varsa destek tedavisi, oksijen ve solunum izlemi gerekir; kusturma ve gastrik lavaj aspirasyon riskini artırdığı için rutin yapılmaz. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.”, “Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.” ve “Akciğer grafisinde aspirasyonla uyumlu infiltratif görünüm izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oksijen ve solunum desteğiyle izlem; kusturma ve gastrik lavajdan kaçınma en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuk gaz yağı içtikten hemen sonra öksürük ve kusma yaşamıştır.

Kanıt 2: Muayenede takipne, hışıltı ve oksijen düşüklüğü vardır.

Kanıt 3: Akciğer grafisinde aspirasyonla uyumlu infiltratif görünüm izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamakta yerine geçmez.

Exam Pearl: Hidrokarbon zehirlenmesinde sorun sistemik toksisiteden çok aspirasyondur; kusturma yapılmaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 175: v182-new-175-orak-hucreli-cocukta-ani-solukluk

Başlık: Orak hücreli çocukta ani solukluk

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Orak hücreli hastalıkta akut splenik sekestrasyonda acil transfüzyon yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, ani gelişen halsizlik, solukluk ve karın şişliği nedeniyle acile getiriliyor. Orak hücreli anemi tanısı olduğu öğreniliyor. Ailesi sabah saatlerinde çocuğun aniden halsizleştiğini, karın sol tarafında şişlik fark ettiklerini ve normalden daha soluk görüldüğünü belirtiyor. Ateş tarifi lenmiyor.

Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 78/46 mmHg | Nabız: 158/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 2,03 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk belirgin soluk ve letarjiktir.
- Dalak sol kosta kenarın 6 cm altında palpe edilir.
- Kapiller dolum süresi 4 saniyedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Bazal değerine göre belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Akut ağır anemiye destekler. | Sonuç yorumu: Akut ağır anemiye destekler. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Bazal değerine göre belirgin düşük saptandı. | Yorum: Akut ağır anemiye destekler. | Satırlar: Hemoglobin / 4.8 g/dL / Akut ağır anemiye destekler.

Tetkik 2: Retikülosit sayısı

Etiket: Retikülosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kemik iliği yanıtının sürdüğünü gösterir. | Sonuç yorumu: Kemik iliği yanıtının sürdüğünü gösterir. | Sonuç başlığı: Retikülosit sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kemik iliği yanıtının sürdüğünü gösterir. | Satırlar: Retikülosit sayısı / Yüksek saptandı. / Kemik iliği yanıtının sürdüğünü gösterir.

Tetkik 3: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Dalakta hücresele sekestrasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Dalakta hücresele sekestrasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Dalakta hücresele sekestrasyonu destekler. | Satırlar: Trombosit sayısı / 76000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Dalakta hücresele sekestrasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği
- B) Oral demir tedavisi
- C) Antibiyotiksiz ayaktan izlem planlamak
- D) Elektif splenektomi randevusu verilmesi
- E) İmmün trombositopeni düşünülerek yalnız steroid verilmesi

Doğru Cevap: Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği

A) Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği: Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği splenik sekestrasyona bağlı ağır anemi ve şoku hedefler. Vakadaki “Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.” ve “Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Oral demir tedavisi: Vakadaki Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır ve Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir. Bu olguda “Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.” ve “Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Antibiyotiksiz ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır ve Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir. Bu olguda “Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.” ve “Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Elektif splenektomi randevusu verilmesi: Splenektomi tekrarlayan olgularda planlanabilir ancak akut şok tablosunda ilk tedavi transfüzyon ve stabilizasyondur. Bu olguda “Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.” ve “Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) İmmün trombositopeni düşünülerek yalnız steroid verilmesi: Steroid immün trombositopenide kullanılabilir; bu olguda temel sorun orak hücre hastalığına bağlı splenik sekestrasyondur. Bu olguda “Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.” ve “Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Orak hücreli çocukta ani solukluk olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.” ve “Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği seçeneği öne çıkar; “Hemoglobin bazale göre çok düşmüş ve trombositopeni saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Orak hücreli çocukta ani ağır anemi, hızla büyüyen splenomegali, trombositopeni ve hipovolemik şok bulguları akut splenik sekestrasyonu düşündürür. Bu hayati tehdit eden tabloda acil dolaşım desteği ve eritrosit süspansiyonu transfüzyonu gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.”, “Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.” ve “Hemoglobin bazale göre çok düşmüş ve trombositopeni saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ve dolaşım desteği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocukta bilinen orak hücreli anemi vardır.

Kanıt 2: Ani solukluk, letarji ve belirgin splenomegali gelişmiştir.

Kanıt 3: Hemoglobin bazale göre çok düşmüş ve trombositopeni saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Orak hücreli çocukta ani splenomegali ve ağır anemi akut splenik sekestrasyondur; acil transfüzyon gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 176: v182-new-176-aglama-sonrasi-morarma-atagi

Başlık: Ağlama sonrası morarma atağı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Fallot tetralojisinde hipersiyanotik atakta ilk müdahaleyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, ağlama sonrası ani artan morarma ve huzursuzluk nedeniyle acile getiriliyor. Fallot tetralojisi tanısıyla takip edildiği öğreniliyor. Ailesi bebeğin beslenme ve ağlama sırasında zaman zaman morardığını, bu kez morarmanın daha uzun sürdüğünü belirtiyor.

Demografi: 9 aylık erkek bebek | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/54 mmHg | Nabız: 168/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %68% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,95 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek huzursuz, takipneik ve santral siyanozedir.
- Kardiyak oskültasyonda üfürüm önceki kontrollere göre daha hafif duyulmaktadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte ilk uygulanması gereken acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek
B) İndometazin vererek duktusu kapatmak
C) Acil servisten ayaktan kontrol planlamak
D) Sıvı kısıtlaması ve diüretik başlamak
E) Oral antibiyotik vermek

Doğru Cevap: Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek

A) Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek: Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme hipersiyanotik atakta sağdan sola şantı azaltmaya yönelik doğru ilk yaklaşımdır. Vakadaki "Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır." ve "Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) İndometazin vererek duktusu kapatmak: Vakadaki Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır ve Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır. Bu olguda "Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır." ve "Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Acil servisten ayaktan kontrol planlamak: Vakadaki Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır ve Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır. Bu olguda "Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır." ve "Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Sıvı kısıtlaması ve diüretik başlamak: Sıvı kısıtlaması ve diüretik sağ ventrikül çıkım obstrüksiyonu olan atakta ön yükü azaltarak tabloyu kötüleştirir. Bu olguda "Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır." ve "Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oral antibiyotik vermek: Vakadaki Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır ve Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır. Bu olguda "Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır." ve "Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ağlama sonrası morarma atağı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır." ve "Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır." birlikte okunduğunda Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek seçeneği öne çıkar; "Oksijen satürasyonu çok düşüktür ve üfürümün azalması sağ çıkım akımının azaldığını düşündürür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Fallot tetralojisinde ağlama sonrası ani derin siyanoz ve huzursuzluk hipersiyanotik atağı düşündürür. İlk yaklaşım diz-göğüs pozisyonu ile sistemik vasküler direnci artırmak, oksijen vermek, çocuğu sakinleştirmek ve gerekirse morfin, sıvı ve beta bloker gibi ek tedavilere geçmektir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır.", "Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır." ve "Oksijen satürasyonu çok düşüktür ve üfürümün azalması sağ çıkım akımının azaldığını düşündürür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Diz-göğüs pozisyonu, oksijen ve sakinleştirme ile hipersiyanotik atağı yönetmek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte Fallot tetralojisi tanısı vardır.

Kanıt 2: Atak ağlama sonrası ani belirgin siyanoz ve huzursuzlukla başlamıştır.

Kanıt 3: Oksijen satürasyonu çok düşüktür ve üfürümün azalması sağ çıkım akımının azaldığını düşündürür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Fallot hipersiyanotik atağında diz-göğüs pozisyonu sistemik vasküler direnci artırarak sağdan sola şantı azaltmaya yardım eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 177: v182-new-177-sicak-su-yanigi

Başlık: Sıcak su yanığı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocuk yanığında sıvı resüsitasyonu ve ilk yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, üzerine sıcak su dökülmesi sonrası gövde ve uyluklarda yanık nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 30 dakika önce üzerine kaynar su döküldüğü öğreniliyor. Aile, yanık alanına uygunsuz bir topikal uygulama yaptıktan sonra acile başvurmuştur. Çocuk ağlamakta ancak bilinci açıktır.

Demografi: 4 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 92/58 mmHg | Nabız: 136/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,48 (yüksek)

Fizik Muayene

- Ön gövde ve her iki uyluğun ön yüzünde ağrılı, bülülü, pembe-kırmızı parsiyel kalınlıkta yanık alanları vardır.
- Hava yolu etkilenimi bulgusu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yanık yüzdesi klinik değerlendirmesi

Etiket: Yanık yüzdesi klinik değerlendirmesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toplam vücut yüzey alanının yaklaşık yüzde 18'i etkilenmiş değerlendirildi. | Klinik anlam: Sıvı resüsitasyonu gereksinimini destekler. | Sonuç yorumu: Sıvı resüsitasyonu gereksinimini destekler. | Sonuç başlığı: Yanık yüzdesi klinik değerlendirmesi | Sonuç özeti: Toplam vücut yüzey alanının yaklaşık yüzde 18'i etkilenmiş değerlendirildi. | Yorum: Sıvı resüsitasyonu gereksinimini destekler. | Satırlar: Yanık yüzdesi klinik değerlendirmesi / 18 % / / Sıvı resüsitasyonu gereksinimini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak
- B) Yanık alanını soğutma ve steril örtüleme sonrası yalnız ayakta pansumanla izlemek
- C) Analjezi ve oral hidrasyonla yakın ayakta izlem planlamak
- D) Bülleri erken dönemde geniş şekilde debride edip primer kapama planlamak
- E) Profilaktik sistemik antibiyotik başlamak ve sıvı resüsitasyonunu klinik izleme bırakmak

Doğru Cevap: Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak

A) Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak: Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı başlamak geniş çocuk yanığında uygun ilk yaklaşımdır. Vakadaki "Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır." ve "Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir." ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Yanık alanını soğutma ve steril örtüleme sonrası yalnız ayakta pansumanla izlemek: Yanık alanını soğutma ve steril örtüleme doğru bakımın bir parçasıdır ancak geniş yüzey alanlı çocuk yanığında sıvı resüsitasyonu ve sistemik değerlendirme ertelenemez. Bu olguda "Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır." ve "Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir." ifadeleri tedavi önceliği açısından Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Analjezi ve oral hidrasyonla yakın ayakta izlem planlamak: Analjezi ve oral hidrasyon destekleyici olabilir ancak geniş çocuk yanığında intravasküler hacim kaybı riski nedeniyle intravenöz izotonik sıvı yaklaşımı gerekir. Bu olguda "Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır." ve "Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir." ifadeleri tedavi önceliği açısından Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Bülleri erken dönemde geniş şekilde debride edip primer kapama planlamak: Bül yönetimi steril koşullarda ve yanık derinliğine göre planlanmalıdır; erken geniş debridman ve primer kapama ilk acil yaklaşım değildir. Bu olguda "Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır." ve "Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir." ifadeleri tedavi önceliği açısından Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Profilaktik sistemik antibiyotik başlamak ve sıvı resüsitasyonunu klinik izleme bırakmak: Profilaktik sistemik antibiyotik her yanıkta rutin değildir ve geniş yanıkta sıvı resüsitasyonunun yerini tutmaz. Bu olguda "Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır." ve "Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir." ifadeleri tedavi önceliği açısından Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sıcak su yanığı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır." ve "Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir." birlikte okunduğunda Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneği öne çıkar; "Yaklaşık yüzde 18 vücut yüzey alanı etkilenmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çocukta yaklaşık yüzde 18 vücut yüzey alanını tutan parsiyel kalınlıkta yanık sıvı kaybı ve hipovolemi riski taşır. İlk yaklaşım hava yolunu değerlendirmek, yanık alanını uygun şekilde temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak, steril örtmek ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlatmaktır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır.", "Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir." ve "Yaklaşık yüzde 18 vücut yüzey alanı etkilenmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Yanık alanını temizlemek, ağrı kontrolü sağlamak ve intravenöz izotonik sıvı resüsitasyonu başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuğun yanığı sıcak suyla oluşmuştur ve geniş alanı tutmaktadır.

Kanıt 2: Yanık alanları bülülü ve parsiyel kalınlıkta görünmektedir.

Kanıt 3: Yaklaşık yüzde 18 vücut yüzey alanı etkilenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Çocuklarda geniş yanıkta hava yolu, ağrı kontrolü, temiz örtme ve sıvı resüsitasyonu erken önceliklerdir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 178: v182-new-178-havuzdan-cikarilma-sonrasi-oksurok

Başlık: Havuzdan çıkarılma sonrası öksürük

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Boğulma sonrası hipokseminde ilk destek tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, havuzda kısa süre su altında kaldıktan sonra öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle acile getiriliyor. Yaklaşık 2 dakika su altında kaldığı, çıkarıldıktan sonra öksürdüğü ve kısa süre morardığı öğreniliyor. Bilinci acile gelirken açıktır ancak nefes almakta zorlandığını söylemektedir.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 102/64 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 36/dk | SpO₂: %89% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,25 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk takipneiktir ve öksürmektedir.
- Akciğerlerde bilateral raller duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Bilateral perihiler hafif infiltratif dansiteler izlendi. | Klinik anlam: Aspirasyon ve akciğer hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Aspirasyon ve akciğer hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Bilateral perihiler hafif infiltratif dansiteler izlendi. | Yorum: Aspirasyon ve akciğer hasarını destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Bilateral perihiler hafif infiltratif dansiteler izlendi. // Aspirasyon ve akciğer hasarını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-094 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Bilateral perihiler hafif infiltratif dansiteler izlendi. | Klinik anlam: Aspirasyon ve akciğer hasarını destekler. | URL: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/094_094-bilateral-perihiler-infiltratif-dansite-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/094_094-bilateral-perihiler-infiltratif-dansite-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Bilateral perihiler hafif infiltratif dansiteler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem
B) Sırtına bası yaparak akciğerdeki suyu çıkarmaya çalışmak
C) Semptomlara rağmen ayaktan izlem planlamak
D) Rutin profilaktik antibiyotik başlamak
E) Antitussif semptomatik tedavi vermek

Doğru Cevap: Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem

- A) Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem: Oksijen desteği ve yakın solunum izlemi boğulma sonrası hipoksemi ve aspirasyon bulguları olan çocukta doğru ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.” ve “Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Sırtına bası yaparak akciğerdeki suyu çıkarmaya çalışmak: Vakadaki Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır ve Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır. Bu olguda “Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.” ve “Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Semptomlara rağmen ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır ve Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır. Bu olguda “Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.” ve “Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Rutin profilaktik antibiyotik başlamak: Profilaktik antibiyotik temiz havuz suyu aspirasyonunda rutin değildir; enfeksiyon bulgusu gelişirse değerlendirilir. Bu olguda “Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.” ve “Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Antitussif semptomatik tedavi vermek: Vakadaki Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır ve Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır. Bu olguda “Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.” ve “Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Havuzdan çıkarılma sonrası öksürük olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.” ve “Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.” birlikte okunduğunda Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem seçeneği öne çıkar; “Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Boğulma sonrası temel sorun hipoksemi ve aspirasyona bağlı akciğer hasarındır. Öksürük, raller ve oksijen satürasyonunda düşme olan çocukta ilk yaklaşım oksijen desteği, solunum durumunun izlenmesi ve gerekirse ileri solunum desteğidir; akciğerdeki suyu mekanik olarak çıkarma girişimleri uygun değildir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.”, “Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.” ve “Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oksijen desteği ve solunum durumuna göre yakın izlem en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuk kısa süre su altında kalmış ve çıkarıldıktan sonra morarmıştır.

Kanıt 2: Muayenede takipne, öksürük ve bilateral raller vardır.

Kanıt 3: Oksijen satürasyonu oda havasında düşüktür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Boğulma sonrası ilk öncelik oksijenasyon ve ventilasyon desteğidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 179: v182-new-179-dka-tedavisi-sirasinda-bilinc-kotulesmesi

Başlık: DKA tedavisi sırasında bilinç kötüleşmesi

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Diyabetik ketoasidoz tedavisinde serebral ödem gelişirse acil tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, tedavinin üçüncü saatinde baş ağrısı, kusma ve bilinçte kötüleşme gelişmesi nedeniyle yeniden değerlendiriliyor. Yeni tanı tip 1 diyabet ve diyabetik ketoasidoz nedeniyle izotonik sıvı ve intravenöz insülin tedavisi başlanmıştır. Başlangıçta koopere olan hastada son 30 dakikada huzursuzluk ve uykuya eğilim gelişmiştir.

Demografi: 10 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 132/86 mmHg | Nabız: 62/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 0,47

Fizik Muayene

- Çocuk somnolandır ve ağırlı uyaranla zor uyanmaktadır.
- Pupiller eşit ancak ışık yanıtı yavaşlamıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum glukoz

Etiket: Serum glukoz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Tedaviyle düşüş göstermiştir. | Klinik anlam: DKA tedavisi devam ederken nörolojik kötüleşme gelişmiştir. | Sonuç yorumu: DKA tedavisi devam ederken nörolojik kötüleşme gelişmiştir. | Sonuç başlığı: Serum glukoz | Sonuç özeti: Tedaviyle düşüş göstermiştir. | Yorum: DKA tedavisi devam ederken nörolojik kötüleşme gelişmiştir. | Satırlar: Serum glukoz / 260 mg/dL / 70-140 mg/dL / DKA tedavisi devam ederken nörolojik kötüleşme gelişmiştir.

Tetkik 2: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük-normal düzeyde saptandı. | Klinik anlam: Serebral ödem risk değerlendirmesinde önemlidir. | Sonuç yorumu: Serebral ödem risk değerlendirmesinde önemlidir. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük-normal düzeyde saptandı. | Yorum: Serebral ödem risk değerlendirmesinde önemlidir. | Satırlar: Serum sodyum / 132 mmol/L / 135-145 mmol/L / Serebral ödem risk değerlendirmesinde önemlidir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması
B) Bilinç kötüleşmesi geçene kadar tüm sıvı ve insülinin kesilip izlenmesi
C) Oral su verilerek susuzluğun giderilmesi
D) Ayaktan izlem planlanması
E) Ateş düşürücü verilmesi

Doğru Cevap: Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması

- A) Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması: Hipertonik salin veya mannitol tedavisi DKA sırasında gelişen serebral ödem şüphesinde acil osmotik tedavi sağlar. Vakadaki “Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.” ve “Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Bilinç kötüleşmesi geçene kadar tüm sıvı ve insülinin kesilip izlenmesi: Vakadaki Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir ve Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır. Bu olguda “Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.” ve “Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Oral su verilerek susuzluğun giderilmesi: Oral su bilinç bozukluğu olan çocukta aspirasyon riski taşır ve kafa içi basınç artışını tedavi etmez. Bu olguda “Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.” ve “Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ayaktan izlem planlanması: Vakadaki Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir ve Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır. Bu olguda “Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.” ve “Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Ateş düşürücü verilmesi: Vakadaki Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir ve Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır. Bu olguda “Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.” ve “Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: DKA tedavisi sırasında bilinç kötüleşmesi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.” ve “Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.” birlikte okunduğunda Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması seçeneği öne çıkar; “Bradikardi ve hipertansiyon kafa içi basınç artışı lehine bulgulardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: DKA tedavisi sırasında baş ağrısı, kusma, bilinç kötüleşmesi, bradikardi ve hipertansiyon serebral ödemi düşündürür. Bu durum görüntüleme beklenmeden acil tedavi gerektirir; hipertonik salin veya mannitol başlanmalı, yoğun bakım ve hava yolu değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.”, “Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.” ve “Bradikardi ve hipertansiyon kafa içi basınç artışı lehine bulgulardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hipertonik salin veya mannitol tedavisi başlanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Nörolojik kötüleşme DKA tedavisi sırasında gelişmiştir.

Kanıt 2: Baş ağrısı, kusma ve somnolans serebral ödem açısından uyarıcıdır.

Kanıt 3: Bradikardi ve hipertansiyon kafa içi basınç artışı lehine bulgulardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: DKA’da serebral ödem şüphesinde görüntüleme beklenmeden hipertonik salin veya mannitol verilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 180: v182-new-180-alci-sonrasi-artan-ekstremitte-agrisi

Başlık: Alçı sonrası artan ekstremitte ağrısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Ekstremitte travması sonrası kompartman sendromunda acil fasyotomi gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, ön kol kırığı nedeniyle alçıldıktan sonra giderek artan şiddetli ağrı ve parmaklarda uyuşma nedeniyle acile getiriliyor. Aynı gün radius-ulna kırığı nedeniyle kapalı redüksiyon ve alçı yapıldığı öğreniliyor. Ailesi ağrının verilen analjeziklere rağmen giderek arttığını ve çocuğun parmaklarını hareket ettirmekte zorlandığını belirtiyor.

Demografi: 11 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,18 (yüksek)

Fizik Muayene

- Ön kol alçısı gergin görünmektedir.
- Parmaklarda pasif ekstansiyonla belirgin ağrı artışı vardır.
- Parmaklarda parestezi tariflenir ve kapiller dolum gecikmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı
B) Seri nörovasküler muayene ile kompartman basıncı değerlendirmesini polikliniğe bırakmak
C) Nabız alındığı için kompartman sendromunu dışlamak
D) Oral antibiyotik başlanması
E) Bir hafta sonra rutin poliklinik kontrolü

Doğru Cevap: Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı

A) Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı: Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı kompartman sendromunda doku iskemisini önleyen doğru yaklaşımdır. Vakadaki "Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır." ve "Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Seri nörovasküler muayene ile kompartman basıncı değerlendirmesini polikliniğe bırakmak: Vakadaki Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır ve Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır. Bu olguda "Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır." ve "Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Nabız alındığı için kompartman sendromunu dışlamak: Vakadaki Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır ve Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır. Bu olguda "Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır." ve "Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Oral antibiyotik başlanması: Vakadaki Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır ve Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır. Bu olguda "Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır." ve "Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Bir hafta sonra rutin poliklinik kontrolü: Vakadaki Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır ve Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır. Bu olguda "Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır." ve "Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Alçı sonrası artan ekstremitte ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır." ve "Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır." birlikte okunduğunda Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı seçeneği öne çıkar; "Pasif parmak ekstansiyonuyla ağrı artışı ve parestezi vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kırık ve alçı sonrası analjeziye yanıtız şiddetli ağrı, pasif germe ile ağrının artması, parestezi ve perfüzyon bozulması akut kompartman sendromunu düşündürür. İlk yaklaşım sıkı alçıyı gevşetmek, ekstremitteyi kalp seviyesinde tutmak ve gecikmeden ortopediyle acil fasyotomi değerlendirmesi yapmaktır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır.", "Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır." ve "Pasif parmak ekstansiyonuyla ağrı artışı ve parestezi vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Alçının gevşetilmesi ve acil ortopedi değerlendirmesiyle fasyotomi hazırlığı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakın zamanda ön kol kırığı sonrası alçı uygulanmıştır.

Kanıt 2: Ağrı analjeziklere rağmen giderek artmaktadır.

Kanıt 3: Pasif parmak ekstansiyonuyla ağrı artışı ve parestezi vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Kompartman sendromunda nabız geç döneme kadar korunabilir; en erken ve önemli bulgu pasif germe ile artan şiddetli ağrıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 181: v183-new-181-omuz-travmasi-sonrasi-abduksiyon-guclugu

Başlık: Omuz travması sonrası abdüksiyon güclüğü

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Humerus cerrahi boyun kırığında nervus axillaris hasarını motor ve duyu bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, düşme sonrası sağ omuz ağrısı ve kolunu yana kaldırmada güçlük nedeniyle başvuruyor. Evde düşerken sağ omzunun üzerine çarptığını, olaydan sonra omuz ağrısı ve kolunu aktif olarak yana kaldıramama geliştiğini belirtiyor. Daha önce omuz hareketlerinde belirin kısıtlılık yoktur.

Demografi: 68 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ omuz çevresinde hassasiyet ve hareket kısıtlılığı vardır.
- Omuz abdüksiyonunun özellikle 15 dereceden sonra belirgin zayıf olduğu izlenir.
- Sağ omuz lateral üst kısmında duyu azalması saptanır.
- El bileği ve parmak ekstansiyonu korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Omuz grafisi

Etiket: Omuz grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Humerus cerrahi boyun düzeyinde kırık izlendi. | Klinik anlam: Bölgesel sinir hasarı açısından riskli kırık lokalizasyonudur. | Sonuç yorumu: Bölgesel sinir hasarı açısından riskli kırık lokalizasyonudur. | Sonuç başlığı: Omuz grafisi | Sonuç özeti: Humerus cerrahi boyun düzeyinde kırık izlendi. | Yorum: Bölgesel sinir hasarı açısından riskli kırık lokalizasyonudur. | Satırlar: Omuz grafisi / Humerus cerrahi boyun düzeyinde kırık izlendi. // Bölgesel sinir hasarı açısından riskli kırık lokalizasyonudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-095 | Başlık: Omuz grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Humerus cerrahi boyun düzeyinde kırık izlendi. | Klinik anlam: Bölgesel sinir hasarı açısından riskli kırık lokalizasyonudur. | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/095_095-humerus-cerrahi-boyun-kirigi-omuz-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/095_095-humerus-cerrahi-boyun-kirigi-omuz-grafisi.webp | Alt text: Omuz grafisi - Humerus cerrahi boyun düzeyinde kırık izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma olasılığı en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus axillaris
B) Nervus radialis
C) Nervus medianus
D) Nervus ulnaris
E) Nervus musculocutaneus

Doğru Cevap: Nervus axillaris

- A) Nervus axillaris: Nervus axillaris humerus cerrahi boyun komşuluğunda seyreder ve deltoid güçsüzlüğü ile lateral omuz duyusu kaybını açıklar. Vakadaki "Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir." ve "Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Nervus radialis: Nervus radialis humerus şaftının spiral oluğu ile ilişkilidir ve el bileği ekstansiyon kaybı beklenir; bu hastada el bileği ekstansiyonu korunmuştur. Bu olguda "Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir." ve "Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nervus medianus: Nervus medianus ön kol fleksörleri ve tenar kaslarla ilişkilidir; omuz abdüksiyonu ve lateral omuz duyusunu açıklamaz. Bu olguda "Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir." ve "Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nervus ulnaris: Nervus ulnaris el intrinsek kasları ve ulnar duyu alanıyla ilişkilidir; cerrahi boyun kırığı sonrası deltoid bulgusunu açıklamaz. Bu olguda "Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir." ve "Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus musculocutaneus: Nervus musculocutaneus dirsek fleksiyonu ve lateral ön kol duyusuyla ilişkilidir; lateral omuz duyu kaybı ve deltoid zayıflığı için en uygun sinir değildir. Bu olguda "Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir." ve "Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus axillaris seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Omuz travması sonrası abdüksiyon güclüğü olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir." ve "Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır." birlikte okunduğunda Nervus axillaris seçeneği öne çıkar; "Omuz lateral üst kısmında duyu azalması saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Humerus cerrahi boyun kırığı, quadrangular aralıktan geçen nervus axillaris için risk oluşturur. Deltoid kas güçsüzlüğüne bağlı omuz abdüksiyon kaybı ve lateral üst kol üzerindeki duyu azalması bu sinir hasarıyla uyumludur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.", "Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır." ve "Omuz lateral üst kısmında duyu azalması saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus axillaris en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Travma sonrası humerus cerrahi boyun kırığı gösterilmiştir.

Kanıt 2: Omuz abdüksiyonu belirgin zayıflamıştır.

Kanıt 3: Omuz lateral üst kısmında duyu azalması saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Humerus cerrahi boyun kırığında nervus axillaris; humerus şaft kırığında nervus radialis düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 182: v183-new-182-yuz-enfeksiyonu-sonrasi-cift-gorme

Başlık: Yüz enfeksiyonu sonrası çift görme

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Kavernöz sinüs patolojisinde nervus abducens etkilenebilir göz hareketi bulgusuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, burun çevresindeki enfeksiyon sonrası başlayan ateş, baş ağrısı ve çift görme nedeniyle başvuruyor. Üç gün önce burun kenarında ağrılı sivilce benzeri lezyonu sıklığını, sonrasında ateş ve göz çevresinde ağrı geliştiğini belirtiyor. Çift görmenin özellikle sağa bakmaya çalışırken arttığını ifade ediyor.

Demografi: 34 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.6°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta febril ve ağrılı görünmektedir.
- Sağ gözde periorbital ödem ve konjonktival konjesyon vardır.
- Sağ göz lateral bakışta abduksiyon yapamamaktadır.
- Sağ alın ve kornea duyusunda hafif azalma vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans venografi

Etiket: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans venografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ kavernöz sinüs düzeyinde trombozla uyumlu dolum defekti izlendi. | Klinik anlam: Kavernöz sinüs içeriğiyle ilişkili nörolojik bulguları destekler. | Sonuç yorumu: Kavernöz sinüs içeriğiyle ilişkili nörolojik bulguları destekler. | Sonuç başlığı: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans venografi | Sonuç özet: Sağ kavernöz sinüs düzeyinde trombozla uyumlu dolum defekti izlendi. | Yorum: Kavernöz sinüs içeriğiyle ilişkili nörolojik bulguları destekler. | Satırlar: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans venografi / Sağ kavernöz sinüs düzeyinde trombozla uyumlu dolum defekti izlendi. / / Kavernöz sinüs içeriğiyle ilişkili nörolojik bulguları destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-096 | Başlık: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans venografi | Modalite: mri | Bulgu: Sağ kavernöz sinüs düzeyinde trombozla uyumlu dolum defekti izlendi. | Klinik anlam: Kavernöz sinüs içeriğiyle ilişkili nörolojik bulguları destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/096_096-kavernoz-sinus-trombozu-mrv.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/096_096-kavernoz-sinus-trombozu-mrv.webp | Alt text: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans venografi - Sağ kavernöz sinüs düzeyinde trombozla uyumlu dolum defekti izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada sağ gözün lateral bakış yapamamasını en iyi açıklayan sinir etkilenebilir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Okulomotor sinir
B) Troklear sinir
C) Abdusens siniri
D) Optik sinir
E) Nervus facialis

Doğru Cevap: Abdusens siniri

A) Okulomotor sinir: Okulomotor sinir birçok ekstraoküler kası ve pupilla parasempatik liflerini etkiler; izole lateral bakış kaybını en iyi açıklamaz. Bu olguda “Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.” ve “Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abdusens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Troklear sinir: Troklear sinir musculus obliquus superior kasını innerve eder ve vertikal diplopiyle ilişkilidir; lateral rektus fonksiyonunu sağlamaz. Bu olguda “Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.” ve “Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abdusens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Abdusens siniri: Abdusens siniri musculus rectus lateralis kasını innerve ettiği için ipsilateral göz abduksiyon kaybını doğrudan açıklar. Vakadaki “Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.” ve “Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Optik sinir: Vakadaki Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir ve Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir. Bu olguda “Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.” ve “Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abdusens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus facialis: Nervus facialis mimik kaslarını innerve eder; lateral bakış kısıtlılığının motor siniri değildir. Bu olguda “Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.” ve “Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abdusens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yüz enfeksiyonu sonrası çift görme olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.” ve “Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.” birlikte okunduğunda Abdusens siniri seçeneği öne çıkar; “Sağ göz lateral bakışta abduksiyon yapamamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kavernöz sinüs trombozunda sinüs içinden geçen kraniyal sinirler etkilenebilir. Abdusens siniri, musculus rectus lateralis kasını innerve eder; bu sinirin hasarı ipsilateral gözde abduksiyon kaybı ve horizontal diplopi oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.”, “Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.” ve “Sağ göz lateral bakışta abduksiyon yapamamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Abdusens siniri en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Burun çevresi enfeksiyonu sonrası kavernöz sinüs trombozu gelişmiştir.

Kanıt 2: Çift görme sağa bakışta belirginleşmektedir.

Kanıt 3: Sağ göz lateral bakışta abduksiyon yapamamaktadır.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguya uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Kavernöz sinüste nervus abducens serbest olarak sinüs içinden geçtiği için kolay etkilenebilir ve lateral bakış kaybı yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 183: v183-new-183-yuksek-irtifada-hizli-soluma

Başlık: Yüksek irtifada hızlı soluma

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Yüksek irtifada gelişen solunumsal alkalozun renal kompanzasyonunu açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yüksek irtifaya çıktıktan sonra baş ağrısı, baş dönmesi ve hızlı soluma yakınmasıyla başvuruyor. Deniz seviyesinden kısa sürede 3500 metreye çıktığını, ilk gün içinde nefes alıp vermesinin hızlandığını ve uyumakta zorlandığını belirtiyor. Bilinen akciğer veya kalp hastalığı yoktur.

Demografi: 26 yaşında sağlıklı erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 98/dk | Solunum: 26/dk | SpO₂: %90% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,83

Fizik Muayene

- Hasta hafif huzursuzdur ve takipneiktir.
- Akciğer oskültasyonu doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Solunumsal alkaloz saptandı. | Klinik anlam: Hipoksik hiperventilasyon yanıtını destekler. | Sonuç yorumu: Hipoksik hiperventilasyon yanıtını destekler. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Solunumsal alkaloz saptandı. | Yorum: Hipoksik hiperventilasyon yanıtını destekler. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.49, PaCO₂ 28, HCO₃ 21 mmHg ve mmol/L / pH 7.35-7.45, PaCO₂ 35-45 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/L / Hipoksik hiperventilasyon yanıtını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tabloya birkaç gün içinde gelişecek temel renal kompanzasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bikarbonat atılımının artması
B) Bikarbonat geri emiliminin belirgin artması
C) Karbondioksit üretiminin böbrekte artması
D) Hidrojen iyonu sekresyonunun aşırı artması
E) Glukoz filtrasyonunun tamamen durması

Doğru Cevap: Bikarbonat atılımının artması

- A) Bikarbonat atılımının artması: Bikarbonat atılımının artması solunumsal alkalozda pH yükselmesini sınırlandıran temel renal kompanzasyondur. Vakadaki "Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır." ve "Hipoksemi ve takipne vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Bikarbonat geri emiliminin belirgin artması: Bikarbonat geri emiliminin artması alkalozu derinleştirir ve yüksek irtifa hiperventilasyonuna uygun kompanzasyon değildir. Bu olguda "Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır." ve "Hipoksemi ve takipne vardır." ipuçları klinik karar açısından Bikarbonat atılımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Karbondioksit üretiminin böbrekte artması: Vakadaki Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır ve Hipoksemi ve takipne vardır. Bu olguda "Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır." ve "Hipoksemi ve takipne vardır." ipuçları klinik karar açısından Bikarbonat atılımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Hidrojen iyonu sekresyonunun aşırı artması: Hidrojen iyonu sekresyonunun aşırı artması alkalozu artırır; kompansatuvar yanıt bunun ters yönündedir. Bu olguda "Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır." ve "Hipoksemi ve takipne vardır." ipuçları klinik karar açısından Bikarbonat atılımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Glukoz filtrasyonunun tamamen durması: Vakadaki Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır ve Hipoksemi ve takipne vardır. Bu olguda "Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır." ve "Hipoksemi ve takipne vardır." ipuçları klinik karar açısından Bikarbonat atılımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yüksek irtifada hızlı soluma olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır." ve "Hipoksemi ve takipne vardır." birlikte okunduğunda Bikarbonat atılımının artması seçeneği öne çıkar; "Kan gazında düşük PaCO₂ ile alkaloz saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yüksek irtifada hipoksemi periferik kemoreseptörleri uyarak hiperventilasyona ve PaCO₂ düşüşüne neden olur. Bu primer solunumsal alkalozu böbrekler bikarbonat geri emilimini azaltıp bikarbonat atılımını artırarak kompanse eder. Bu olguda kararın temel ayırımı, "Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır.", "Hipoksemi ve takipne vardır." ve "Kan gazında düşük PaCO₂ ile alkaloz saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Bikarbonat atılımının artması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta kısa sürede yüksek irtifaya çıkmıştır.

Kanıt 2: Hipoksemi ve takipne vardır.

Kanıt 3: Kan gazında düşük PaCO₂ ile alkaloz saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Solunumsal alkalozun renal kompanzasyonu bikarbonat atılımını artırmaktır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 184: v183-new-184-glomeruler-filtrasyonun-lokal-kontrolu

Başlık: Glomerüler filtrasyonun lokal kontrolü

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Tubuloglomerüler geri bildirimde makula densanın afferent arteriyol tonusunu nasıl düzenlediğini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde distal tübüle ulaşan sodyum klorür yükü arttığında glomerüler filtrasyon hızındaki lokal düzenleme tartışılıyor. Bilinen böbrek hastalığı, hipertansiyon veya ilaç kullanımı yoktur. Çalışma fizyolojik mekanizmayı değerlendirmek için simülasyon verileri üzerinden yapılmaktadır.

Demografi: 24 yaşında sağlıklı kadın gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 76/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,68

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Fizik muayenede patolojik bulgu saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Simülasyon bulgusu

Etiket: Simülasyon bulgusu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Makula densaya ulaşan sodyum klorür miktarı artmış olarak modellendi. | Klinik anlam: Tubuloglomerüler geri bildirim tetikleyen sinyaldir. | Sonuç yorumu: Tubuloglomerüler geri bildirim tetikleyen sinyaldir. | Sonuç başlığı: Simülasyon bulgusu | Sonuç özeti: Makula densaya ulaşan sodyum klorür miktarı artmış olarak modellendi. | Yorum: Tubuloglomerüler geri bildirim tetikleyen sinyaldir. | Satırlar: Simülasyon bulgusu / Makula densaya ulaşan sodyum klorür miktarı artmış olarak modellendi. // Tubuloglomerüler geri bildirim tetikleyen sinyaldir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü arttığında beklenen lokal fizyolojik yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması
B) Afferent arteriyol vazodilatasyonu ile glomerüler filtrasyon hızının artırılması
C) Efferent arteriyol tam kapanmasıyla filtrasyonun tamamen durması
D) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunun artması
E) Toplayıcı kanalda aquaporinlerin tamamen kaybolması

Doğru Cevap: Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması

- A) Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması: Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu yüksek makula densa sodyum klorür sinyaline verilen doğru tubuloglomerüler geri bildirim yanıtıdır. Vakadaki “Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.” ve “Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Afferent arteriyol vazodilatasyonu ile glomerüler filtrasyon hızının artırılması: Afferent vazodilatasyon glomerüler filtrasyonu artırır; yüksek distal sodyum klorür yükünü düzeltici yönde değildir. Bu olguda “Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.” ve “Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Efferent arteriyol tam kapanmasıyla filtrasyonun tamamen durması: Vakadaki Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur ve Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır. Bu olguda “Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.” ve “Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunun artması: Proksimal tübülde glukoz sekresyonu bu mekanizmanın parçası değildir; glukoz esas olarak geri emilir. Bu olguda “Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.” ve “Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Toplayıcı kanalda aquaporinlerin tamamen kaybolması: Toplayıcı kanalda aquaporin düzenlenmesi antidiüretik hormonla ilişkilidir; makula densa sodyum klorür sinyalinin temel yanıtı değildir. Bu olguda “Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.” ve “Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Glomerüler filtrasyonun lokal kontrolü olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.” ve “Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.” birlikte okunduğunda Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması seçeneği öne çıkar; “Yanıt aynı nefrondaki glomerüler filtrasyon hızını düzenlemeye yöneliktir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Makula densaya yüksek sodyum klorür ulaşması, nefron akımının ve filtrasyonun yüksek olduğunu gösteren bir sinyaldir. Tubuloglomerüler geri bildirim aracılığıyla afferent arteriyolde vazokonstriksiyon gelişir ve glomerüler kapiller basınç düşerek glomerüler filtrasyon hızı azaltılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.”, “Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.” ve “Yanıt aynı nefrondaki glomerüler filtrasyon hızını düzenlemeye yöneliktir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Afferent arteriyol vazokonstriksiyonu ile glomerüler filtrasyon hızının azaltılması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Değerlendirilen mekanizma renal otoregülasyondur.

Kanıt 2: Makula densaya ulaşan sodyum klorür yükü artmıştır.

Kanıt 3: Yanıt aynı nefrondaki glomerüler filtrasyon hızını düzenlemeye yöneliktir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Makula densada sodyum klorür artışı afferent vazokonstriksiyonla glomerüler filtrasyon hızını azaltır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 185: v183-new-185-cocukta-hiperurisemi-ve-kendine-zarar-verme

Başlık: Çocukta hiperürisemi ve kendine zarar verme

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Lesch-Nyhan sendromunda pürin kurtarma yolu defektini klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, gelişim geriliği, istemsiz hareketler ve dudaklarını ısırma davranışı nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun motor gelişiminin yaştlarına göre geri olduğunu, son aylarda dudak ve parmaklarını ısırarak kendine zarar verdiğini belirtiyor. Bezlerinde zaman zaman turuncu-kırmızı kristal benzeri lekeler fark edilmiştir.

Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Çocukta distonik hareketler ve spastisite izlenir.
- Dudaklarda eski ısırma izleri vardır.
- Eklemlerde akut artrit bulgusu yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum ürik asit

Etiket: Serum ürik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Pürin metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Pürin metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Serum ürik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Pürin metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Serum ürik asit / 10.8 mg/dL / 2.5-6.0 mg/dL / Pürin metabolizması bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: İdrar ürik asit atılımı

Etiket: İdrar ürik asit atılımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Artmış saptandı. | Klinik anlam: Aşırı ürik asit üretimini destekler. | Sonuç yorumu: Aşırı ürik asit üretimini destekler. | Sonuç başlığı: İdrar ürik asit atılımı | Sonuç özeti: Artmış saptandı. | Yorum: Aşırı ürik asit üretimini destekler. | Satırlar: İdrar ürik asit atılımı / Artmış saptandı. // Aşırı ürik asit üretimini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel biyokimyasal defekt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
C) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği
D) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği
E) Glukoz-6-fosfataz eksikliği

Doğru Cevap: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği

A) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği Lesch-Nyhan sendromunda hiperürisemi ve kendine zarar verme davranışını açıklar. Vakadaki "Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır." ve "Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüriye yol açar; hiperürisemi ve kendine zarar verme paternini açıklamaz. Bu olguda "Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır." ve "Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği akçaağaç şurubu idrar hastalığına neden olur; ürik asit artışı temel bulgu değildir. Bu olguda "Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır." ve "Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği galaktozemide sütle beslenme sonrası hepatik bulgular yapar. Bu olguda "Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır." ve "Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği glikojen depo hastalığı tip I ile ilişkilidir; bu nörodavranışsal ve pürin kurtarma yolu bulgularını açıklamaz. Bu olguda "Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır." ve "Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir." ipuçları klinik karar açısından Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Çocukta hiperürisemi ve kendine zarar verme olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır." ve "Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir." birlikte okunduğunda Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneği öne çıkar; "Serum ürik asit ve idrar ürik asit atılımı artmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erkek çocukta nörolojik bulgular, kendine zarar verme davranışı, turuncu ürat kristalleri ve hiperürisemi Lesch-Nyhan sendromunu düşündürür. Temel defekt pürin kurtarma yolunda görevli hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliğidir; pürinlerin de novo sentezi artar ve ürik asit üretimi yükselir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır.", "Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir." ve "Serum ürik asit ve idrar ürik asit atılımı artmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada kendine zarar verme davranışı ve nörolojik bulgular vardır.

Kanıt 2: Bezlerde ürat kristallerini düşündüren turuncu-kırmızı lekeler tariflenmiştir.

Kanıt 3: Serum ürik asit ve idrar ürik asit atılımı artmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanitten ayrılır.

Exam Pearl: Lesch-Nyhan sendromu X'e bağlıdır ve HGPR eksikliğiyle pürin kurtarma yolu bozulur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 186: v183-new-186-uzun-boy-ve-lens-subluksasyonu

Başlık: Uzun boy ve lens subluksasyonu

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Metiyonin metabolizması ve homosistinüride enzim defektini klinik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, görme bulanıklığı, uzun-ince vücut yapısı ve tekrarlayan bacak ağrısı öyküsü nedeniyle başvuruyor. Çocukluk döneminden beri öğrenme güçlüğü olduğu, son aylarda görme bulanıklığının arttığı öğreniliyor. Ailede akraba evliliği vardır. Daha önce derin ven trombozu nedeniyle değerlendirilmiştir.

Demografi: 15 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta uzun boylu ve ince yapılıdır.
- Göğüs deformitesi hafiftir.
- Göz muayenesinde lensin inferonazal yönde sublukse olduğu belirtilir.
- Nörolojik muayenede hafif gelişimsel gerilik izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma homosistein

Etiket: Plazma homosistein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Homosistein metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Homosistein metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma homosistein | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Homosistein metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Plazma homosistein / Belirgin yüksek saptandı. // Homosistein metabolizması bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: Plazma metiyonin

Etiket: Plazma metiyonin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Klasik homosistinüri lehine destekleyicidir. | Sonuç yorumu: Klasik homosistinüri lehine destekleyicidir. | Sonuç başlığı: Plazma metiyonin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Klasik homosistinüri lehine destekleyicidir. | Satırlar: Plazma metiyonin / Yüksek saptandı. // Klasik homosistinüri lehine destekleyicidir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki en olası enzim defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sistationin beta-sentaz eksikliği
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
C) Homogentizat oksidaz eksikliği
D) Galaktokinaz eksikliği
E) Ornitin transkarbamilaz eksikliği

Doğru Cevap: Sistationin beta-sentaz eksikliği

A) Sistationin beta-sentaz eksikliği: Sistationin beta-sentaz eksikliği homosistein ve metiyonin artışıyla klasik homosistinüri tablosunu açıklar. Vakadaki “Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.” ve “Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüri yapar; lens subluksasyonu ve tromboz eğilimi tipik değildir. Bu olguda “Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.” ve “Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.” ipuçları tanısız karar açısından Sistationin beta-sentaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Homogentizat oksidaz eksikliği: Homogentizat oksidaz eksikliği alkaptonüriye neden olur ve koyu idrar ile okronozla ilişkilidir. Bu olguda “Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.” ve “Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.” ipuçları tanısız karar açısından Sistationin beta-sentaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Galaktokinaz eksikliği: Galaktokinaz eksikliği daha çok kataraktla seyredir; homosistein yüksekliği ve tromboz paternini açıklamaz. Bu olguda “Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.” ve “Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.” ipuçları tanısız karar açısından Sistationin beta-sentaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Ornitin transkarbamilaz eksikliği: Ornitin transkarbamilaz eksikliği hiperammonemi ve orotik asit artışıyla ilişkilidir; bu bağ dokusu ve lens bulgularını açıklamaz. Bu olguda “Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.” ve “Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.” ipuçları tanısız karar açısından Sistationin beta-sentaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzun boy ve lens subluksasyonu olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.” ve “Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.” birlikte okunduğunda Sistationin beta-sentaz eksikliği seçeneği öne çıkar; “Plazma homosistein ve metiyonin düzeyleri yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Lens subluksasyonu, marfanoid vücut yapısı, gelişimsel gerilik, tromboz eğilimi ve homosistein-metiyonin yüksekliği klasik homosistinüriye düşündürür. En sık neden metiyonin metabolizmasında görevli sistationin beta-sentaz eksikliğidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.”, “Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.” ve “Plazma homosistein ve metiyonin düzeyleri yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Sistationin beta-sentaz eksikliği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada lens subluksasyonu ve marfanoid vücut yapısı vardır.

Kanıt 2: Tromboz öyküsü homosistein yüksekliğiyle uyumludur.

Kanıt 3: Plazma homosistein ve metiyonin düzeyleri yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Homosistinüride lens genellikle aşağı-içe sublukse olur ve tromboz riski artar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 187: v183-new-187-eriskinde-belirgin-proteinuri

Başlık: Erişkinde belirgin proteinüri

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Membranöz nefropatide nefrotik sendrom ve subepitelyal immün kompleks paternini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacaklarda şişlik ve idrarda köpüklenme nedeniyle başvuruyor. Son üç aydır giderek artan ayak bileği ödemi ve halsizlik tarifliyor. Diyabet öyküsü yoktur. Yakın zamanda belirgin enfeksiyon geçirmemiştir.

Demografi: 54 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 138/82 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,61

Fizik Muayene

- Bilateral pretibial gode bırakan ödem vardır.
- Akciğer oskültasyonu doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: 24 saatlik idrar protein düzeyi

Etiket: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Klinik anlam: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç yorumu: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç başlığı: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Sonuç özeti: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Yorum: Nefrotik sendromu destekler. | Satırlar: 24 saatlik idrar protein düzeyi / 6.4 g/gün / <0.15 g/gün / Nefrotik sendromu destekler.

Tetkik 2: Serum albümin

Etiket: Serum albümin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Protein kaybına bağlı hipoalbuminemi gösterir. | Sonuç yorumu: Protein kaybına bağlı hipoalbuminemi gösterir. | Sonuç başlığı: Serum albümin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Protein kaybına bağlı hipoalbuminemi gösterir. | Satırlar: Serum albümin / 2.3 g/dL / 3.5-5.0 g/dL / Protein kaybına bağlı hipoalbuminemi gösterir.

Tetkik 3: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi

Etiket: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal immün kompleks birikimleri izlendi. | Klinik anlam: Membranöz patern açısından karakteristiktir. | Sonuç yorumu: Membranöz patern açısından karakteristiktir. | Sonuç başlığı: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Sonuç özeti: Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal immün kompleks birikimleri izlendi. | Yorum: Membranöz patern açısından karakteristiktir. | Satırlar: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi / Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal immün kompleks birikimleri izlendi. / / Membranöz patern açısından karakteristiktir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-097 | Başlık: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal immün kompleks birikimleri izlendi. | Klinik anlam: Membranöz patern açısından karakteristiktir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/097_097-subepitelyal-immun-kompleks-birikimi-em.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/097_097-subepitelyal-immun-kompleks-birikimi-em.webp | Alt text: Böbrek biyopsisi elektron mikroskopisi - Glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal immün kompleks birikimleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta ışık mikroskopisi veya özel boyamada beklenen karakteristik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Glomerüler bazal membranda spike görünümü
- B) Kazeifiye granülom oluşumu
- C) Hilal oluşumu olmadan tamamen normal glomerül görünümü
- D) Nodüler mezangial glomerüloskleroz
- E) Subepitelyal hump birikimleri

Doğru Cevap: Glomerüler bazal membranda spike görünümü

- A) Glomerüler bazal membranda spike görünümü: Glomerüler bazal membranda spike görünümü membranöz nefropatide subepitelyal immün kompleks birikimleriyle oluşan karakteristik bulgudur. Vakadaki "Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır." ve "Diyabet öyküsü verilmemiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Kazeifiye granülom oluşumu: Kazeifiye granülom tüberküloz gibi granümatöz inflamasyonlarda beklenir; nefrotik membranöz paterni açıklamaz. Bu olguda "Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır." ve "Diyabet öyküsü verilmemiştir." ipuçları klinik karar açısından Glomerüler bazal membranda spike görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Hilal oluşumu olmadan tamamen normal glomerül görünümü: Tamamen normal glomerül görünümü minimal değişiklik hastalığında ışık mikroskopisi için tipiktir; burada subepitelyal birikimler verilmemiştir. Bu olguda "Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır." ve "Diyabet öyküsü verilmemiştir." ipuçları klinik karar açısından Glomerüler bazal membranda spike görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nodüler mezangial glomerüloskleroz: Nodüler mezangial glomerüloskleroz diyabetik nefropatiyle ilişkilidir; bu hastada diyabet öyküsü yoktur ve subepitelyal birikim paterni vardır. Bu olguda "Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır." ve "Diyabet öyküsü verilmemiştir." ipuçları klinik karar açısından Glomerüler bazal membranda spike görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Subepitelyal hump birikimleri: Subepitelyal hump birikimleri poststreptokoksik glomerülonefritte beklenir; erişkin nefrotik membranöz paterniyle karıştırılmamalıdır. Bu olguda "Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır." ve "Diyabet öyküsü verilmemiştir." ipuçları klinik karar açısından Glomerüler bazal membranda spike görünümü seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erişkinde belirgin proteinüri olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır." ve "Diyabet öyküsü verilmemiştir." birlikte okunduğunda Glomerüler bazal membranda spike görünümü seçeneği öne çıkar; "Elektron mikroskopisinde subepitelyal immün kompleks birikimleri gösterilmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erişkinde nefrotik sendrom ve elektron mikroskopisinde glomerüler bazal membran boyunca subepitelyal immün kompleks birikimleri membranöz nefropatiyi düşündürür. Gümüş boyasıyla immün kompleksler arasındaki bazal membran çıkıntıları spike görünümü oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır.", "Diyabet öyküsü verilmemiştir." ve "Elektron mikroskopisinde subepitelyal immün kompleks birikimleri gösterilmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Glomerüler bazal membranda spike görünümü en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbuminemi vardır.

Kanıt 2: Diyabet öyküsü verilmemiştir.

Kanıt 3: Elektron mikroskopisinde subepitelyal immün kompleks birikimleri gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Membranöz nefropatide subepitelyal birikimler ve spike-dome görünümü klasik bulgulardır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 188: v183-new-188-antihipertansif-sonrasi-kuru-oksuruk

Başlık: Antihipertansif sonrası kuru öksürük

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: ACE inhibitörlerinin öksürük ve anjiyoödem yan etkisini bradikinin mekanizmasıyla açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yeni başlanan tansiyon ilacından sonra gelişen inatçı kuru öksürük nedeniyle başvuruyor. Hipertansiyon nedeniyle üç hafta önce enalapril başladığı öğreniliyor. İlacı kullanmaya başladıktan sonra balgamsız kuru öksürük geliştiğini, ateş veya nefes darlığı olmadığını belirtiyor.

Demografi: 59 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 128/76 mmHg | Nabız: 78/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,61

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Akciğer oskültasyonu doğaldır.
- Orofarenks doğaldır ve hişiltılı solunum yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Patolojik infiltrasyon izlenmedi. | Klinik anlam: Enfeksiyöz akciğer nedenini geri plana iter. | Sonuç yorumu: Enfeksiyöz akciğer nedenini geri plana iter. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Patolojik infiltrasyon izlenmedi. | Yorum: Enfeksiyöz akciğer nedenini geri plana iter. | Satırlar: Akciğer grafisi / Patolojik infiltrasyon izlenmedi. // Enfeksiyöz akciğer nedenini geri plana iter.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-098 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Patolojik infiltrasyon izlenmedi. | Klinik anlam: Enfeksiyöz akciğer nedenini geri plana iter. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/098_098-normal-akciger-grafisi-patolojik-infiltrasyon-yok.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/098_098-normal-akciger-grafisi-patolojik-infiltrasyon-yok.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Patolojik infiltrasyon izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yan etkinin en olası farmakolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bradikinin yıkımının azalması
B) Beta-2 reseptörlerin doğrudan blokajı
C) Histamin H1 reseptörlerinin uyarılması
D) Sodyum kanallarının irreversibl blokajı
E) Dopamin D2 reseptörlerinin antagonizması

Doğru Cevap: Bradikinin yıkımının azalması

A) Bradikinin yıkımının azalması: Bradikinin yıkımının azalması ACE inhibitörlerine bağlı kuru öksürük ve anjiyoödem temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Beta-2 reseptörlerin doğrudan blokajı: Beta-2 reseptör blokajı bronkospazm yapabilir ancak enalaprilin tipik kuru öksürük mekanizması değildir. Bu olguda “Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.” ipuçları tanısal karar açısından Bradikinin yıkımının azalması seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Histamin H1 reseptörlerinin uyarılması: Histamin H1 reseptör uyarılması alerjik belirtilerle ilişkilidir; ACE inhibitörü öksürüğünün temel nedeni bradikinin birikimidir. Bu olguda “Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.” ipuçları tanısal karar açısından Bradikinin yıkımının azalması seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Sodyum kanallarının irreversibl blokajı: Sodyum kanalı blokajı lokal anestezipler veya bazı antiaritmiklerle ilişkilidir; bu tabloyu açıklamaz. Bu olguda “Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.” ipuçları tanısal karar açısından Bradikinin yıkımının azalması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Dopamin D2 reseptörlerinin antagonizması: Dopamin D2 antagonizması ekstrapiramidal yan etkilerle ilişkilidir; kuru öksürük mekanizması değildir. Bu olguda “Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.” ipuçları tanısal karar açısından Bradikinin yıkımının azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antihipertansif sonrası kuru öksürük olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.” ve “Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.” birlikte okunduğunda Bradikinin yıkımının azalması seçeneği öne çıkar; “Akciğer oskültasyonunun doğal olması bronkospazmı geri plana iter.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Enalapril bir ACE inhibitörüdür ve anjiyotensin II oluşumunu azaltırken bradikinin yıkımını da azaltır. Bradikinin birikimi kuru öksürük ve nadiren anjiyoödem gelişiminden sorumludur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.”, “Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.” ve “Akciğer oskültasyonunun doğal olması bronkospazmı geri plana iter.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Bradikinin yıkımının azalması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kuru öksürük enalapril başlandıktan sonra gelişmiştir.

Kanıt 2: Ateş, balgam ve akciğer grafisi bulgusu enfeksiyonu desteklememektedir.

Kanıt 3: Akciğer oskültasyonunun doğal olması bronkospazmı geri plana iter.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: ACE inhibitörü öksürüğü bradikinin birikimiyle ilişkilidir; alternatif olarak anjiyotensin reseptör blokleri düşünülebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 189: v183-new-189-yenidoganda-mekonyum-cikaramama

Başlık: Yenidoğanda mekonyum çıkaramama

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Nöral krest göç kusurunu Hirschsprung hastalığındaki aganglionik segmentle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan sonra mekonyum çıkaramama, karın distansiyonu ve safralı kusma nedeniyle getiriliyor. Miadında doğduğu, doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde mekonyum çıkarmadığı öğreniliyor. Son 12 saatte karın şişliği ve beslenme sonrası yeşil renkli kusma başlamıştır.

Demografi: 3 günlük erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirmesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 150/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 2,14 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebeğe belirgin abdominal distansiyon vardır.
- Rektal tuşe sonrası patlayıcı tarzda gaz ve dışkı çıkışı izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kontrastlı kolon grafisi

Etiket: Kontrastlı kolon grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Distal dar segment ve proksimal dilatasyon izlendi. | Klinik anlam: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | Sonuç yorumu: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | Sonuç başlığı: Kontrastlı kolon grafisi | Sonuç özeti: Distal dar segment ve proksimal dilatasyon izlendi. | Yorum: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | Satırlar: Kontrastlı kolon grafisi / Distal dar segment ve proksimal dilatasyon izlendi. // Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler.

Tetkik 2: Rektal biyopsi

Etiket: Rektal biyopsi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Submukozal ve myenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Klinik anlam: Aganglionik segmenti gösterir. | Sonuç yorumu: Aganglionik segmenti gösterir. | Sonuç başlığı: Rektal biyopsi | Sonuç özeti: Submukozal ve myenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Yorum: Aganglionik segmenti gösterir. | Satırlar: Rektal biyopsi / Submukozal ve myenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. // Aganglionik segmenti gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-099 | Başlık: Kontrastlı kolon grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Distal dar segment ve proksimal dilatasyon izlendi. | Klinik anlam: Fonksiyonel distal obstrüksiyonu destekler. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/099_099-hirschsprung-kontrastli-kolon-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/099_099-hirschsprung-kontrastli-kolon-grafisi.webp | Alt text: Kontrastlı kolon grafisi - Distal dar segment ve proksimal dilatasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-100 | Başlık: Rektal biyopsi | Modalite: microscopy | Bulgu: Submukozal ve myenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Klinik anlam: Aganglionik segmenti gösterir. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/100_100-aganglionik-rektal-biyopsi-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/100_100-aganglionik-rektal-biyopsi-histopatoloji.webp | Alt text: Rektal biyopsi - Submukozal ve myenterik pleksuslarda ganglion hücreleri izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalığın temel embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi
- B) Midgutun superior mezenterik arter etrafında aşırı rotasyonu
- C) Tiroglossal kanalın kapanmaması
- D) Pleuroperitoneal membranın kapanmaması
- E) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu

Doğru Cevap: Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi

A) Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi: Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi enterik plexus aganglionozisini ve fonksiyonel obstrüksiyonu açıklar. Vakadaki “Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Midgutun superior mezenterik arter etrafında aşırı rotasyonu: Midgut rotasyon bozukluğu volvulus ve malrotasyonla ilişkilidir; rektal aganglionozis mekanizması değildir. Bu olguda “Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Tiroglossal kanalın kapanmaması: Tiroglossal kanalın kapanmaması orta hat boyun kisti yapar; mekonyum çıkaramama tablosunu açıklamaz. Bu olguda “Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Pleuroperitoneal membranın kapanmaması: Pleuroperitoneal membranın kapanmaması konjenital diyafram hernisine yol açar; distal kolon aganglionozisiyle ilişkili değildir. Bu olguda “Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu: Septum primumun aşırı rezorpsiyonu atriyal septal defekt mekanizmasıdır; enterik sinir sistemi gelişimini açıklamaz. Bu olguda “Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda mekonyum çıkaramama olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.” ve “Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.” birlikte okunduğunda Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi seçeneği öne çıkar; “Rektal biyopside ganglion hücreleri izlenmemiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Mekonyum çıkaramama, abdominal distansiyon, patlayıcı dışkılama, distal dar segment ve biyopside ganglion hücresi yokluğu Hirschsprung hastalığını düşündürür. Temel mekanizma enterik sinir sistemini oluşturacak nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.”, “Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.” ve “Rektal biyopside ganglion hücreleri izlenmemiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Bebek ilk 48 saat içinde mekonyum çıkaramamıştır.

Kanıt 2: Kontrastlı grafide distal dar segment ve proksimal dilatasyon vardır.

Kanıt 3: Rektal biyopside ganglion hücreleri izlenmemiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Hirschsprung hastalığında rektal biyopside ganglion hücreleri yoktur ve distal segment gevşeyemez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 190: v183-new-190-kasik-sisligi-ve-kusma

Başlık: Kasık şişliği ve kusma

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Boğulmuş inguinal hernide acil cerrahi yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ kasıkta ağrılı şişlik, karın ağrısı ve kusma nedeniyle acile başvuruyor. Yıllardır sağ kasıkta ara sıra çıkan ve elle içeri giren şişliği olduğunu, son 10 saattir şişliğin kaybolmadığını ve ağrısının arttığını belirtiyor. Son saatlerde gaz çıkaramadığını ve birkaç kez kustuğunu ifade ediyor.

Demografi: 63 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/66 mmHg | Nabız: 116/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 37.9°C | Şok indeksi: 1,12 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ inguinal bölgede ağrılı, gergin, redükte edilemeyen kitle vardır.
- Batın distandüdü ve barsak sesleri artmıştır.
- Ciltte hafif eritem izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ayakta direkt karın grafisi

Etiket: Ayakta direkt karın grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: İnce barsak düzeyinde hava-sıvı seviyeleri izlendi. | Klinik anlam: Mekanik barsak obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Mekanik barsak obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Ayakta direkt karın grafisi | Sonuç özeti: İnce barsak düzeyinde hava-sıvı seviyeleri izlendi. | Yorum: Mekanik barsak obstrüksiyonunu destekler. | Satırlar: Ayakta direkt karın grafisi / İnce barsak düzeyinde hava-sıvı seviyeleri izlendi. / / Mekanik barsak obstrüksiyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-101 | Başlık: Ayakta direkt karın grafisi | Modalite: xray | Bulgu: İnce barsak düzeyinde hava-sıvı seviyeleri izlendi. | Klinik anlam: Mekanik barsak obstrüksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/101_101-mekanik-barsak-obstruksiyonu-direkt-karin-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/101_101-mekanik-barsak-obstruksiyonu-direkt-karin-grafisi.webp | Alt text: Ayakta direkt karın grafisi - İnce barsak düzeyinde hava-sıvı seviyeleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım
- B) Ağrılı kitleyi zorlayarak tekrarlı manuel redüksiyon denemek
- C) Ayaktan oral analjezik ve elektif kontrol vermek
- D) Laksatif tedavi başlamak
- E) Herni bağı ile ayaktan izlem planlamak

Doğru Cevap: Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım

A) Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım: Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım redükte edilemeyen ağrılı herni ve obstrüksiyon bulgularında doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.” ve “Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Ağrılı kitleyi zorlayarak tekrarlı manuel redüksiyon denemek: Zorlayıcı manuel redüksiyon strangüle barsağın karın içine itilmesine ve tanının gecikmesine yol açabilir. Bu olguda “Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.” ve “Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Ayaktan oral analjezik ve elektif kontrol vermek: Vakadaki Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır ve Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler. Bu olguda “Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.” ve “Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Laksatif tedavi başlamak: Vakadaki Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır ve Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler. Bu olguda “Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.” ve “Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Herni bağı ile ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır ve Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler. Bu olguda “Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.” ve “Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kasık şişliği ve kusma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.” ve “Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.” birlikte okunduğunda Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım seçeneği öne çıkar; “Karın grafisinde ince barsak hava-sıvı seviyeleri izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Redükte edilemeyen ağrılı inguinal kitle, kusma, gaz çıkaramama, batın distansiyonu ve hava-sıvı seviyeleri inkarsere veya strangüle inguinal herniye bağlı barsak obstrüksiyonunu düşündürür. Strangülasyon riski olduğundan acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.”, “Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.” ve “Karın grafisinde ince barsak hava-sıvı seviyeleri izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil cerrahi değerlendirme ve operatif onarım en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Kasık şişliği artık redükte edilememektedir ve ağrılıdır.

Kanıt 2: Kusma, gaz çıkaramama ve batın distansiyonu obstrüksiyonu destekler.

Kanıt 3: Karın grafisinde ince barsak hava-sıvı seviyeleri izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ağrılı, redükte edilemeyen herniye obstrüksiyon bulguları eşlik ediyorsa strangülasyon riski nedeniyle acil cerrahi gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 191: v184-new-191-erken-gebelikte-karin-agrisi-ve-bayilma

Başlık: Erken gebelikte karın ağrısı ve bayılma

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Ektopik gebelik rüptüründe hemodinamik instabiliteye göre acil cerrahi yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, şiddetli alt karın ağrısı, vajinal lekelenme ve bayılma hissi nedeniyle acile başvuruyor. Son adet tarihine göre yaklaşık 7 haftalık gebe olabileceğini belirtmektedir. Son iki gündür lekelenme tarzı vajinal kanaması olduğu, bugün ani başlayan sağ alt kadranda ağrısı ve omuz ağrısı geliştiği öğreniliyor. Daha önce pelvik inflamatuvar hastalık öyküsü vardır.

Demografi: 29 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,61 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve terli görünümündedir.
- Batında yaygın hassasiyet ve rebound vardır.
- Servikal hareket hassasiyeti belirgindir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum beta-hCG

Etiket: Serum beta-hCG | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Gebelik varlığını destekler. | Sonuç yorumu: Gebelik varlığını destekler. | Sonuç başlığı: Serum beta-hCG | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Gebelik varlığını destekler. | Satırlar: Serum beta-hCG / 4200 mIU/mL // Gebelik varlığını destekler.

Tetkik 2: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; sağ adneksiyel bölgede heterojen kitle ve batında serbest sıvı görüldü. | Klinik anlam: Rüptüre ektopik gebelik olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Rüptüre ektopik gebelik olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; sağ adneksiyel bölgede heterojen kitle ve batında serbest sıvı görüldü. | Yorum: Rüptüre ektopik gebelik olasılığını destekler. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; sağ adneksiyel bölgede heterojen kitle ve batında serbest sıvı görüldü. // Rüptüre ektopik gebelik olasılığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-102 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; sağ adneksiyel bölgede heterojen kitle ve batında serbest sıvı görüldü. | Klinik anlam: Rüptüre ektopik gebelik olasılığını destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/102_102-rupture-ektopik-gebelik-transvajinal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/102_102-rupture-ektopik-gebelik-transvajinal-ultrasonografi.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Uterin kavitede gebelik kesesi izlenmedi; sağ adneksiyel bölgede heterojen kitle ve batında serbest sıvı görüldü. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon
B) Tek doz metotreksat verilir ayaktan takip
C) Beta-hCG değerinin 48 saat sonra tekrarına kadar izlem planlamak
D) Oral analjezikle ayaktan izlem planlamak
E) Rutin progesteron desteği başlamak

Doğru Cevap: Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon

- A) Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon: Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon, rüptür ve şok bulguları olan ektopik gebelikte doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Tek doz metotreksat verilir ayaktan takip: Metotreksat yalnızca hemodinamik olarak stabil ve rüptür bulgusu olmayan seçilmiş ektopik gebeliklerde uygundur. Bu olguda “Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Beta-hCG değerinin 48 saat sonra tekrarına kadar izlem planlamak: Vakadaki Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur ve Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür. Bu olguda “Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Oral analjezikle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur ve Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür. Bu olguda “Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Rutin progesteron desteği başlamak: Vakadaki Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur ve Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür. Bu olguda “Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken gebelikte karın ağrısı ve bayılma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.” birlikte okunduğunda Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide intrauterin gebelik izlenmemiş, adneksiyel kitle ve serbest sıvı görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Pozitif gebelik testi, uterin kavitede gebelik kesesi izlenmemesi, adneksiyel kitle, serbest sıvı, periton bulguları ve hipotansiyon rüptüre ektopik gebeliği düşündürür. Hemodinamik instabilite varlığında metotreksat veya izlem uygun değildir; acil cerrahi ve resüsitasyon gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.”, “Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.” ve “Ultrasonografide intrauterin gebelik izlenmemiş, adneksiyel kitle ve serbest sıvı görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil cerrahi eksplorasyon ve hemodinamik resüsitasyon en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta erken gebelik döneminde karın ağrısı ve vajinal lekelenme ile başvurmuştur.

Kanıt 2: Hipotansiyon, taşikardi ve periton bulguları intraabdominal kanamayı düşündürür.

Kanıt 3: Ultrasonografide intrauterin gebelik izlenmemiş, adneksiyel kitle ve serbest sıvı görülmüştür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamakta yerine geçmez.

Exam Pearl: Ektopik gebelikte hemodinamik instabilite varsa acil cerrahi; stabil seçilmiş olguda metotreksat düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 192: v184-new-192-ani-goz-agrisi-ve-gorme-bulanikligi

Başlık: Ani göz ağrısı ve görme bulanıklığı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Akut aç kapanması glokomunda klinik bulgularla acil tedavi gereksinimini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sol gözde ani başlayan şiddetli ağrı, görme bulanıklığı ve bulantı nedeniyle başvuruyor. Ağrının karanlık bir ortamda film izledikten sonra başladığını, ışıkların etrafında renkli halkalar gördüğünü ve baş ağrısı ile bulantının eşlik ettiğini belirtiyor. Travma öyküsü yoktur.

Demografi: 64 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sol gözde konjonktival hiperemi ve korneal bulanıklık vardır.
- Sol pupil orta derecede dilate ve ışığa yanıtıdır.
- Göz palpasyonla sert hissedilir.
- Sağ göz muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Göz içi basıncı ölçümü

Etiket: Göz içi basıncı ölçümü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sol gözde belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut göz içi basınç artışı gösterir. | Sonuç yorumu: Akut göz içi basınç artışı gösterir. | Sonuç başlığı: Göz içi basıncı ölçümü | Sonuç özeti: Sol gözde belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Akut göz içi basınç artışı gösterir. | Satırlar: Göz içi basıncı ölçümü / 54 mmHg / 10-21 mmHg / Akut göz içi basınç artışı gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut aç kapanması glokomu
B) Basit viral konjonktivit
C) Retina dekolmanı
D) Optik nörit
E) Hordeolum

Doğru Cevap: Akut aç kapanması glokomu

- A) Akut aç kapanması glokomu: Akut aç kapanması glokomu ani ağrılı kırmızı göz, haleler, korneal bulanıklık ve yüksek göz içi basıncıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır." ve "Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Basit viral konjonktivit: Viral konjonktivit genellikle kaşıntı, sulanma ve hafif rahatsızlık yapar; pupil fiksasyonu ve çok yüksek göz içi basıncı beklenmez. Bu olguda "Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır." ve "Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut aç kapanması glokomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Retina dekolmanı: Retina dekolmanı ışık çakmaları, uçan cisimler ve perde inmesiyle seyreder; ağrılı kırmızı göz ve yüksek basınç tipik değildir. Bu olguda "Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır." ve "Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut aç kapanması glokomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Optik nörit: Optik nöritte göz hareketiyle ağrı ve görme kaybı olabilir ancak korneal bulanıklık ve akut basınç yüksekliği beklenmez. Bu olguda "Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır." ve "Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut aç kapanması glokomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Hordeolum: Hordeolum göz kapağında lokal ağrılı nodül yapar; bu hastadaki göz içi basınç artışı açıklamaz. Bu olguda "Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır." ve "Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut aç kapanması glokomu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani göz ağrısı ve görme bulanıklığı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır." ve "Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır." birlikte okunduğunda Akut aç kapanması glokomu seçeneği öne çıkar; "Göz içi basıncı sol gözde belirgin yüksek ölçülmüştür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ani şiddetli göz ağrısı, bulanık görme, haleler, bulantı, korneal bulanıklık, orta dilate ışığa yanıtıdır pupil ve çok yüksek göz içi basıncı akut aç kapanması glokomunu düşündürür. Bu durum görmeyi tehdit eden oftalmolojik acildir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır.", "Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır." ve "Göz içi basıncı sol gözde belirgin yüksek ölçülmüştür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut aç kapanması glokomu en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Göz ağrısı ani ve şiddetli başlamıştır.

Kanıt 2: Haleler, korneal bulanıklık ve orta dilate ışığa yanıtıdır pupil vardır.

Kanıt 3: Göz içi basıncı sol gözde belirgin yüksek ölçülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Ağrılı kırmızı göz, orta dilate pupil ve yüksek göz içi basıncı akut aç kapanması glokomunu düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 193: v184-new-193-kirli-yara-sonrasi-cene-kilitlenmesi

Başlık: Kirli yara sonrası çene kilitlenmesi

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Tetanos kliniğinde etkeni ve toksin etkisini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, çene kilitlenmesi, yutma güçlüğü ve kas spazmları nedeniyle başvuruyor. On gün önce bahçede çalışırken paslı metal parçasıyla ayağından yaralandığını, yarası temizlemeden kapattığını ve tetanos aşısını ne zaman yaptırdığını hatırlamadığını belirtiyor. Son iki gündür çenesini açmakta zorlanmaktadır.

Demografi: 41 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 146/90 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 0,81

Fizik Muayene

- Hastada trismus, risus sardonius görünümü ve uyarıyla artan yaygın kas spazmları vardır.
- Bilinci açıktır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Clostridium tetani
- B) Clostridium botulinum
- C) Corynebacterium diphtheriae
- D) Bacillus anthracis
- E) Listeria monocytogenes

Doğru Cevap: Clostridium tetani

A) Clostridium tetani: Clostridium tetani kirli yara sonrası trismus ve yaygın kas spazmlarıyla seyreden tetanos tablosunun etkenidir. Vakadaki "Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir." ve "Tetanos aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Clostridium botulinum: Clostridium botulinum gevşek paralizi ve kranial sinir bulguları yapar; bu hastada spastik kasılmalar baskındır. Bu olguda "Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir." ve "Tetanos aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları tanısal karar açısından Clostridium tetani seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Corynebacterium diphtheriae: Corynebacterium diphtheriae psödomembranlı farenjit ve miyokardit yapabilir; trismus ve uyarıyla artan spazm tablosunu açıklamaz. Bu olguda "Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir." ve "Tetanos aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları tanısal karar açısından Clostridium tetani seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Bacillus anthracis: Bacillus anthracis eskar veya ağır sistemik enfeksiyonla ilişkilidir; tetanik spazm kliniği beklenmez. Bu olguda "Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir." ve "Tetanos aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları tanısal karar açısından Clostridium tetani seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Listeria monocytogenes: Listeria monocytogenes özellikle yaşlı, gebe ve immünsüpre hastalarda menenjit yapar; kirli yara sonrası trismus kliniğiyle uyumlu değildir. Bu olguda "Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir." ve "Tetanos aşı öyküsü belirsizdir." ipuçları tanısal karar açısından Clostridium tetani seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kirli yara sonrası çene kilitlenmesi olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir." ve "Tetanos aşı öyküsü belirsizdir." birlikte okunduğunda Clostridium tetani seçeneği öne çıkar; "Trismus, risus sardonius ve uyarıyla artan kas spazmları vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kirli penetran yara sonrası trismus, risus sardonius ve uyarıyla artan kas spazmları tetanosu düşündürür. Clostridium tetani tetanospozmin toksiniyle inhibitör nörotransmitter salınımını engeller ve kaslarda rijidite-spazm oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir.", "Tetanos aşı öyküsü belirsizdir." ve "Trismus, risus sardonius ve uyarıyla artan kas spazmları vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Clostridium tetani en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta kirli metal yaralanması geçirmiştir.

Kanıt 2: Tetanos aşı öyküsü belirsizdir.

Kanıt 3: Trismus, risus sardonius ve uyarıyla artan kas spazmları vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Tetanos toksini inhibitör internöronlardan GABA ve glisin salınımını engelleyerek spastik paralizi yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 194: v184-new-194-sag-ust-kadran-agrisi

Başlık: Sağ üst kadran ağrısı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Akut kolesistitte klinik, muayene ve ultrason bulgularıyla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yağlı yemek sonrası başlayan sağ üst kadran ağrısı, bulantı ve ateş nedeniyle başvuruyor. Ağrının 8 saattir sürdüğünü, sağ omuza yayıldığını ve daha önce benzer ancak daha kısa süren ataklar yaşadığını belirtiyor. Kusma ve iştahsızlık eşlik etmektedir.

Demografi: 47 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ üst kadranda belirgin hassasiyet vardır.
- İnspirasyon sırasında palpasyonla ağrı artışı nedeniyle hasta nefesini kesmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut inflamasyonu destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 15100 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Akut inflamasyonu destekler.

Tetkik 2: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Klinik anlam: Akut kolesistit lehine bulgudur. | Sonuç yorumu: Akut kolesistit lehine bulgudur. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Yorum: Akut kolesistit lehine bulgudur. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. // Akut kolesistit lehine bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-103 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Klinik anlam: Akut kolesistit lehine bulgudur. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/103_103-akut-kolesistit-abdominal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/103_103-akut-kolesistit-abdominal-ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Safra kesesinde taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut kolesistit
B) Akut pankreatit
C) Akut apandisit
D) Renal kolik
E) Peptik ülser perforasyonu

Doğru Cevap: Akut kolesistit

A) Akut kolesistit: Akut kolesistit sağ üst kadran ağrısı, ateş, Murphy bulgusu ve ultrasonografik safra kesesi inflamasyonu ile en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır." ve "Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Akut pankreatit: Akut pankreatit genellikle epigastrik sırta yayılan ağrı ve lipaz yüksekliğiyle beklenir; burada safra kesesi inflamasyonu gösterilmiştir. Bu olguda "Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır." ve "Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Akut apandisit: Vakadaki Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır ve Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır. Bu olguda "Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır." ve "Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Renal kolik: Renal kolikte yan ağrısı ve hematüri beklenir; Murphy bulgusu ve safra kesesi duvar kalınlaşması açıklanamaz. Bu olguda "Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır." ve "Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Peptik ülser perforasyonu: Peptik ülser perforasyonunda ani şiddetli ağrı, yaygın peritonit ve serbest hava beklenir; bu olgu lokal biliyer inflamasyonla uyumludur. Bu olguda "Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır." ve "Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır." ipuçları tanısal karar açısından Akut kolesistit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sağ üst kadran ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır." ve "Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır." birlikte okunduğunda Akut kolesistit seçeneği öne çıkar; "Ultrasonografide taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı gösterilmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uzun süren sağ üst kadran ağrısı, ateş, lökositoz, Murphy bulgusu ve ultrasonografide taşla birlikte safra kesesi duvar kalınlaşması akut kolesistiti düşündürür. Biliyer kolikten farklı olarak inflamasyon ve sistemik bulgular eşlik eder. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır.", "Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır." ve "Ultrasonografide taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı gösterilmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut kolesistit en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ağrı sağ üst kadranda uzun sürmüş ve sağ omuza yayılmıştır.

Kanıt 2: Muayenede inspirasyonla artan sağ üst kadran hassasiyeti vardır.

Kanıt 3: Ultrasonografide taş, duvar kalınlaşması ve perikolesistik sıvı gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Akut kolesistitte Murphy bulgusu ve ultrasonografide safra kesesi duvar kalınlaşması önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 195: v184-new-195-nazal-biyopsi-ve-epitel-tipi

Başlık: Nazal biyopsi ve epitel tipi

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik veriyi hedeflenen karar noktasıyla eşleştirme.

Learning Target: Respiratuvar epitelin histolojik özelliklerini klinik bağlamda tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kronik burun tıkanıklığı nedeniyle yapılan nazal mukoza biyopsisi sonucunu öğrenmek için başvuruyor. Uzun süredir alerjik rinit yakınmaları olduğunu, özellikle mevsimsel dönemde burun akıntısı ve hapşırıklarının arttığını belirtmektedir. Sigara kullanmamaktadır.

Demografi: 38 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Nazal mukozada ödemli ve soluk görünüm vardır.
- Pürülan akıntı veya septal perforasyon izlenmez.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Nazal mukoza biyopsisi

Etiket: Nazal mukoza biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel ve goblet hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Respiratuvar epitel tipini gösterir. | Sonuç yorumu: Respiratuvar epitel tipini gösterir. | Sonuç başlığı: Nazal mukoza biyopsisi | Sonuç özeti: Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel ve goblet hücreleri izlendi. | Yorum: Respiratuvar epitel tipini gösterir. | Satırlar: Nazal mukoza biyopsisi / Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel ve goblet hücreleri izlendi. // Respiratuvar epitel tipini gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-104 | Başlık: Nazal mukoza biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel ve goblet hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Respiratuvar epitel tipini gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/104_104-respiratuvar-epitel-nazal-mukoza-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/104_104-respiratuvar-epitel-nazal-mukoza-histopatoloji.webp | Alt text: Nazal mukoza biyopsisi - Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel ve goblet hücreleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu biyopsi bulgusunda tanımlanan epitel tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Respiratuvar epitel
B) Çok katlı yassı keratinize epitel
C) Tek katlı yassı epitel
D) Geçiş epiteli
E) Tek katlı kübik epitel

Doğru Cevap: Respiratuvar epitel

- A) Respiratuvar epitel: Respiratuvar epitel yalancı çok katlı silli prizmatik yapı ve goblet hücreleriyle nazal mukozadaki bulguyu açıklar. Vakadaki “Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.” ve “Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Çok katlı yassı keratinize epitel: Çok katlı yassı keratinize epitel derinin epidermisinde beklenir; silli goblet hücreli nazal mukoza paternine uymaz. Bu olguda “Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.” ve “Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Respiratuvar epitel seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Tek katlı yassı epitel: Tek katlı yassı epitel alveol ve endotel gibi difüzyon yüzeylerinde bulunur; goblet hücresi ve silya içermez. Bu olguda “Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.” ve “Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Respiratuvar epitel seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Geçiş epiteli: Geçiş epiteli üriner sistemin gerilebilir yüzeylerinde bulunur; nazal respiratuvar mukozayı tanımlamaz. Bu olguda “Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.” ve “Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Respiratuvar epitel seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Tek katlı kübik epitel: Tek katlı kübik epitel küçük kanallar ve bazı tübüllerde görülür; yalancı çok katlı silli yapı değildir. Bu olguda “Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.” ve “Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Respiratuvar epitel seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Nazal biyopsi ve epitel tipi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.” ve “Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Respiratuvar epitel seçeneği öne çıkar; “Goblet hücrelerinin varlığı mukus üreten respiratuvar mukozayı destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nazal kavite ve iletili hava yollarının tipik epiteli yalancı çok katlı silli prizmatik epitel olup goblet hücreleri içerir. Bu yapı mukus üretimi ve mukosiliyer temizleme için özelleştirilmiştir ve respiratuvar epitel olarak adlandırılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.”, “Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.” ve “Goblet hücrelerinin varlığı mukus üreten respiratuvar mukozayı destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Respiratuvar epitel en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Biyopsi nazal mukozadan alınmıştır.

Kanıt 2: Yalancı çok katlı silli prizmatik epitel izlenmiştir.

Kanıt 3: Goblet hücrelerinin varlığı mukus üreten respiratuvar mukozayı destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanitten ayrılır.

Exam Pearl: Respiratuvar epitel yalancı çok katlı silli prizmatik epitel ve goblet hücreleriyle tanınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 196: v184-new-196-duygudurum-ilaci-sonrasi-tremor-ve-konfuzyon

Başlık: Duygudurum ilacı sonrası tremor ve konfüzyon

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Lityum toksisitesinde klinik bulgularla tedavi yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tremor, ishal, kusma ve bilinç bulanıklığı nedeniyle acile getiriliyor. Bipolar bozukluk nedeniyle lityum kullandığı, son günlerde susuz kaldığı ve ağrı için nonsteroid antiinflatuvar ilaç aldığı öğreniliyor. Yakınları konuşmasının yavaşladığını ve dengesiz yürüdüğünü belirtmektedir.

Demografi: 46 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 96/58 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,17 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta konfüzidir.
- Kaba tremor ve ataksi vardır.
- Mukozalar kurudur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum lityum düzeyi

Etiket: Serum lityum düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ciddi lityum toksisitesini destekler. | Sonuç yorumu: Ciddi lityum toksisitesini destekler. | Sonuç başlığı: Serum lityum düzeyi | Sonuç özeti: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Yorum: Ciddi lityum toksisitesini destekler. | Satırlar: Serum lityum düzeyi / 3.1 mEq/L / 0.6-1.2 mEq/L / Ciddi lityum toksisitesini destekler.

Tetkik 2: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Renal atılım azalmasını destekler. | Sonuç yorumu: Renal atılım azalmasını destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Renal atılım azalmasını destekler. | Satırlar: Serum kreatinin / 2.0 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Renal atılım azalmasını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek
- B) Lityum dozunu artırmak
- C) Oral aktif kömür vermek
- D) Protamin sülfat uygulamak
- E) Asetilsistein başlamak

Doğru Cevap: Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek

A) Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek: Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve hemodiyalizi değerlendirmek ciddi lityum toksisitesinde doğru yaklaşımdır. Vakadaki "Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır." ve "Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler." ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Lityum dozunu artırmak: Vakadaki Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır ve Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler. Bu olguda "Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır." ve "Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler." ifadeleri tedavi önceliği açısından Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Oral aktif kömür vermek: Vakadaki Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır ve Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler. Bu olguda "Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır." ve "Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler." ifadeleri tedavi önceliği açısından Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Protamin sülfat uygulamak: Vakadaki Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır ve Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler. Bu olguda "Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır." ve "Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler." ifadeleri tedavi önceliği açısından Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Asetilsistein başlamak: Vakadaki Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır ve Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler. Bu olguda "Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır." ve "Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler." ifadeleri tedavi önceliği açısından Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Duygudurum ilacı sonrası tremor ve konfüzyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır." ve "Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler." birlikte okunduğunda Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek seçeneği öne çıkar; "Serum lityum düzeyi toksik, kreatinin düzeyi yüksek saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Lityum toksisitesinde gastrointestinal yakınmalar, kaba tremor, ataksi, konfüzyon ve renal fonksiyon bozukluğu görülebilir. Lityum kesilmeli, hacim kaybı izotonik sıvıyla düzeltilmeli ve ciddi nörolojik bulgu veya yüksek düzey varlığında hemodiyaliz değerlendirilmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır.", "Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler." ve "Serum lityum düzeyi toksik, kreatinin düzeyi yüksek saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Lityumu kesmek, izotonik sıvı vermek ve ciddi nörolojik toksisite nedeniyle hemodiyalizi değerlendirmek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta lityum kullanırken dehidratasyon ve nonsteroid antiinflatuvar ilaç maruziyeti yaşamıştır.

Kanıt 2: Kaba tremor, ataksi ve konfüzyon ciddi nörolojik toksisiteyi destekler.

Kanıt 3: Serum lityum düzeyi toksik, kreatinin düzeyi yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Lityum böbrekten atılır; dehidratasyon ve NSAİİ kullanımı toksisite riskini artırır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 197: v184-new-197-apendektomi-materyalinde-inflamasyon

Başlık: Apendektomi materyalinde inflamasyon

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Akut apandisitte tanı koydurucu histopatolojik bulguyu ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ alt kadranda ağrısı nedeniyle opere edilmiş ve çıkarılan apendiks histopatolojik incelemeye gönderilmiştir. Ağrının periumbilikal başlayıp sağ alt kadrana yerleştiği, bulantı ve iştahsızlığın eşlik ettiği öğreniliyor. Cerrahi sırasında apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür.

Demografi: 23 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Operasyon öncesi sağ alt kadranda rebound ve defans saptanmıştır.
- Postoperatif dönemde genel durumu stabildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Apendiks histopatolojisi

Etiket: Apendiks histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu izlendi. | Klinik anlam: Akut apandisit için tanı koydurucu histolojik bulgudur. | Sonuç yorumu: Akut apandisit için tanı koydurucu histolojik bulgudur. | Sonuç başlığı: Apendiks histopatolojisi | Sonuç özeti: Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu izlendi. | Yorum: Akut apandisit için tanı koydurucu histolojik bulgudur. | Satırlar: Apendiks histopatolojisi / Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu izlendi. // Akut apandisit için tanı koydurucu histolojik bulgudur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Akut apandisit tanısı için en karakteristik histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu
B) Submukozada nonkazeifiye granülomlar
C) Goblet hücreli intestinal metaplazi
D) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma
E) Epidermiste akantoz ve hiperkeratoz

Doğru Cevap: Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu

- A) Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu: Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu akut apandisit için karakteristik ve tanı koydurucu bulgudur. Vakadaki "Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır." ve "Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Submukozada nonkazeifiye granülomlar: Nonkazeifiye granülomlar Crohn hastalığı veya sarkoidoz gibi granümatöz süreçleri düşündürür. Bu olguda "Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır." ve "Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür." ipuçları tanısal karar açısından Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Goblet hücreli intestinal metaplazi: Goblet hücreli intestinal metaplazi Barrett özofagusu gibi metaplazik süreçlerle ilişkilidir; akut apandisit bulgusu değildir. Bu olguda "Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır." ve "Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür." ipuçları tanısal karar açısından Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma: Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma amiloid birikimini gösterir; akut apendiks inflamasyonunu tanımlamaz. Bu olguda "Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır." ve "Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür." ipuçları tanısal karar açısından Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Epidermiste akantoz ve hiperkeratoz: Akantoz ve hiperkeratoz epidermal değişikliklerdir; apendiks duvarındaki akut inflamasyonla ilişkili değildir. Bu olguda "Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır." ve "Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür." ipuçları tanısal karar açısından Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Apendektomi materyalinde inflamasyon olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır." ve "Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür." birlikte okunduğunda Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu seçeneği öne çıkar; "Histolojide apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Akut apandisit histolojik tanısında en önemli bulgu muskularis propria uzanan, yani duvarı tutan nötrofil infiltrasyonudur. Sadece lümeninde nötrofil görülmesi tanı için yeterli değildir; transmural akut inflamasyon tanısal değerdedir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır.", "Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür." ve "Histolojide apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada tipik sağ alt kadranda ağrısı ve periton bulguları vardır.

Kanıt 2: Cerrahide apendiks ödemli ve hiperemik görülmüştür.

Kanıt 3: Histolojide apendiks duvarında transmural nötrofil infiltrasyonu saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Akut apandisitte tanı koydurucu histolojik bulgu muskularis propria tutan nötrofil infiltrasyonudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 198: v184-new-198-aclikta-hipoglisemi-ve-hepatomegali

Başlık: Açlıkta hipoglisemi ve hepatomegali

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Von Gierke hastalığında glukoz-6-fosfataz eksikliğini klinik ve metabolik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, açlık dönemlerinde terleme, huzursuzluk ve nöbet benzeri ataklar nedeniyle getiriliyor. Aile, beslenme araları uzadığında bebeğin soluklaştığını, terlediğini ve huzursuzlaştığını belirtiyor. Karın şişliğinin giderek arttığı fark edilmiştir. Akraba evliliği vardır.

Demografi: 8 aylık erkek bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebekte belirgin hepatomegali ve karın distansiyonu vardır.
- Büyüme geriliği izlenir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Açlık kan glukozu

Etiket: Açlık kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Açlık hipoglisemisini gösterir. | Sonuç yorumu: Açlık hipoglisemisini gösterir. | Sonuç başlığı: Açlık kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Açlık hipoglisemisini gösterir. | Satırlar: Açlık kan glukozu / 38 mg/dL / 70-100 mg/dL / Açlık hipoglisemisini gösterir.

Tetkik 2: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Laktik asidozu destekler. | Sonuç yorumu: Laktik asidozu destekler. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Laktik asidozu destekler. | Satırlar: Serum laktat / 6.2 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L / Laktik asidozu destekler.

Tetkik 3: Serum ürik asit

Etiket: Serum ürik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Metabolik yönelmeyi destekler. | Sonuç yorumu: Metabolik yönelmeyi destekler. | Sonuç başlığı: Serum ürik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Metabolik yönelmeyi destekler. | Satırlar: Serum ürik asit / 9.4 mg/dL / 2.5-6.0 mg/dL / Metabolik yönelmeyi destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel biyokimyasal defekt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Glukoz-6-fosfataz eksikliği
B) Asit alfa-glukozidaz eksikliği
C) Lizozomal beta-glukoserebrozidaz eksikliği
D) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
E) Ornitin transkarbamilaz eksikliği

Doğru Cevap: Glukoz-6-fosfataz eksikliği

- A) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği açlık hipoglisemisi, hepatomegali, laktik asidoz ve hiperürisemi tablosunu açıklar. Vakadaki "Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır." ve "Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Asit alfa-glukozidaz eksikliği: Asit alfa-glukozidaz eksikliği Pompe hastalığına neden olur ve kardiyomiopati ile hipotoni ön plandadır. Bu olguda "Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır." ve "Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır." ipuçları klinik karar açısından Glukoz-6-fosfataz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Lizozomal beta-glukoserebrozidaz eksikliği: Beta-glukoserebrozidaz eksikliği Gaucher hastalığıyla ilişkilidir; açlık hipoglisemisi ve laktik asidozun temel nedeni değildir. Bu olguda "Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır." ve "Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır." ipuçları klinik karar açısından Glukoz-6-fosfataz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüri yapar; hepatomegali ve açlık hipoglisemisi beklenen ana bulgular değildir. Bu olguda "Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır." ve "Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır." ipuçları klinik karar açısından Glukoz-6-fosfataz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Ornitin transkarbamilaz eksikliği: Ornitin transkarbamilaz eksikliği hiperammonemiyle seyreder; bu Vakadaki glikojenoliz son basamak bozukluğunu açıklamaz. Bu olguda "Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır." ve "Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır." ipuçları klinik karar açısından Glukoz-6-fosfataz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlıkta hipoglisemi ve hepatomegali olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır." ve "Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır." birlikte okunduğunda Glukoz-6-fosfataz eksikliği seçeneği öne çıkar; "Laktat ve ürik asit düzeyleri yüksek saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Açlık hipoglisemisi, hepatomegali, laktik asidoz ve hiperürisemi glikojen depo hastalığı tip I olan Von Gierke hastalığını düşündürür. Glukoz-6-fosfataz eksikliği nedeniyle karaciğer glikojenoliz ve glukoneogenez son ürününü serbest glukozu çeviremez. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır.", "Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır." ve "Laktat ve ürik asit düzeyleri yüksek saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Glukoz-6-fosfataz eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Belirtiler beslenme araları uzadığında ortaya çıkmaktadır.

Kanıt 2: Açlık hipoglisemisi ve belirgin hepatomegali vardır.

Kanıt 3: Laktat ve ürik asit düzeyleri yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Von Gierke hastalığında glukoz-6-fosfataz eksikliği açlık hipoglisemisi, laktik asidoz ve hepatomegali yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 199: v184-new-199-egzersizde-oksijen-birakilmesi

Başlık: Egzersizde oksijen bırakılması

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Hemoglobin-oksijen disosiasyon eğrisinde sağa kaymayı doku oksijen sunumuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde yoğun egzersiz sırasında iskelet kasına oksijen bırakılmasını artıran faktörler tartışılıyor. Bilinen kronik hastalığı yoktur. Değerlendirme, egzersiz sırasında kas dokusunda oluşan fizyolojik değişiklikleri anlamaya yöneliktir.

Demografi: 22 yaşında sağlıklı erkek gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Kas dokusunda metabolik aktivite artışı beklenmektedir.
- Dinlenimde fizik muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fizyolojik simülasyon

Etiket: Fizyolojik simülasyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Aktif kas dokusunda karbondioksit, hidrojen iyonu ve sıcaklık artışı modellendi. | Klinik anlam: Hemoglobin-oksijen ayrışma eğrisinin yönünü etkileyen faktörlerdir. | Sonuç yorumu: Hemoglobin-oksijen ayrışma eğrisinin yönünü etkileyen faktörlerdir. | Sonuç özeti: Aktif kas dokusunda karbondioksit, hidrojen iyonu ve sıcaklık artışı modellendi. | Yorum: Hemoglobin-oksijen ayrışma eğrisinin yönünü etkileyen faktörlerdir. | Satırlar: Fizyolojik simülasyon / Aktif kas dokusunda karbondioksit, hidrojen iyonu ve sıcaklık artışı modellendi. // Hemoglobin-oksijen ayrışma eğrisinin yönünü etkileyen faktörlerdir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu değişikliklerin hemoglobin-oksijen disosiasyon eğrisine ve doku oksijenlenmesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar
B) Eğri sola kayar ve hemoglobinin oksijeni bırakması artar
C) Eğri sağa kayar ve oksijen bırakılması azalır
D) Eğri değişmez çünkü pH ve sıcaklık oksijen bağlanmasını etkilemez
E) Hemoglobin oksijeni geri dönüşümsüz şekilde bağlar

Doğru Cevap: Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar

A) Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar: Eğrinin sağa kayması hemoglobinin oksijene afinitesini azaltır ve aktif dokulara oksijen bırakılmasını artırır. Vakadaki “Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.” ve “Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Eğri sola kayar ve hemoglobinin oksijeni bırakması artar: Sola kayma hemoglobinin oksijene afinitesini artırır ve dokulara oksijen bırakılmasını azaltır. Bu olguda “Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.” ve “Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Eğri sağa kayar ve oksijen bırakılması azalır: Vakadaki Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir ve Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir. Bu olguda “Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.” ve “Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Eğri değişmez çünkü pH ve sıcaklık oksijen bağlanmasını etkilemez: Vakadaki Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir ve Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir. Bu olguda “Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.” ve “Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hemoglobin oksijeni geri dönüşümsüz şekilde bağlar: Hemoglobin oksijeni geri dönüşümlü bağlar; fizyolojik oksijen taşınması bu geri dönüşümlülüğe dayanır. Bu olguda “Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.” ve “Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Egzersizde oksijen bırakılması olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.” ve “Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.” birlikte okunduğunda Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar seçeneği öne çıkar; “Sıcaklık artışı hemoglobinin oksijen afinitesini azaltan faktörlerden biridir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Aktif dokuda artan karbondioksit, hidrojen iyonu ve sıcaklık hemoglobinin oksijene afinitesini azaltarak disosiasyon eğrisini sağa kaydırır. Bu Bohr etkisi, metabolik aktivitesi yüksek dokulara oksijen bırakılmasını kolaylaştırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.”, “Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.” ve “Sıcaklık artışı hemoglobinin oksijen afinitesini azaltan faktörlerden biridir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Eğri sağa kayar ve hemoglobinin oksijeni dokuya bırakması artar en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Değerlendirme yoğun egzersiz sırasında aktif iskelet kasına yöneliktir.

Kanıt 2: Aktif dokuda karbondioksit ve hidrojen iyonu artışı modellenmiştir.

Kanıt 3: Sıcaklık artışı hemoglobinin oksijen afinitesini azaltan faktörlerden biridir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Karbondioksit, asit, sıcaklık ve 2, 3-BPG artışı eğriyi sağa kaydırır ve oksijen salınımını artırır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 200: v184-new-200-laparoskopik-kolesistektomi-sirasinda-anatomik-alan

Başlık: Laparoskopik kolesistektomi sırasında anatomik alan

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Safra kesesi cerrahisinde ductus cysticus ve arteria cystica ilişkisini Calot üçgeni üzerinden açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Cerrahi sırasında safra kesesi boynu çevresindeki anatomik yapıların güvenli şekilde tanımlanması gerekmektedir. Hasta, tekrarlayan yağlı yemek sonrası sağ üst kadranda ağrıları nedeniyle elektif cerrahiye planlanmıştır. Daha önce üst batin cerrahisi geçirmemiştir.

Demografi: 52 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Operasyon öncesi vital bulguları stabildir.
- Batın muayenesinde akut peritonit bulgusu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Preoperatif abdominal ultrasonografi

Etiket: Preoperatif abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Safra kesesi içinde multipl taş izlendi; koledok dilatasyonu saptanmadı. | Klinik anlam: Elektif kolesistektomi endikasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Elektif kolesistektomi endikasyonunu destekler. | Sonuç özeti: Safra kesesi içinde multipl taş izlendi; koledok dilatasyonu saptanmadı. | Yorum: Elektif kolesistektomi endikasyonunu destekler. | Satırlar: Preoperatif abdominal ultrasonografi / Safra kesesi içinde multipl taş izlendi; koledok dilatasyonu saptanmadı. // Elektif kolesistektomi endikasyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-105 | Başlık: Preoperatif abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Safra kesesi içinde multipl taş izlendi; koledok dilatasyonu saptanmadı. | Klinik anlam: Elektif kolesistektomi endikasyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/105_105-safra-kesesi-taslari-preoperatif-abdominal-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/105_105-safra-kesesi-taslari-preoperatif-abdominal-ultrasonografi.webp | Alt text: Preoperatif abdominal ultrasonografi - Safra kesesi içinde multipl taş izlendi; koledok dilatasyonu saptanmadı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Laparoskopik kolesistektomide güvenli diseksiyon için tanımlanan Calot üçgeninin temel sınırları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı
B) Ductus choledochus, vena porta ve arteria hepatica communis
C) Mide küçük kurvaturu, pylorus ve duodenum birinci kısmı
D) Arteria mesenterica superior, vena splenica ve pankreas boynu
E) Ligamentum teres hepatis, ligamentum falciforme ve umbilikal ven kalıntısı

Doğru Cevap: Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı

- A) Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı: Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı Calot üçgeninin modern cerrahi sınırlarını oluşturur. Vakadaki "Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır." ve "Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır." ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Ductus choledochus, vena porta ve arteria hepatica communis: Ductus choledochus, vena porta ve arteria hepatica communis hepatoduodenal ligament içeriğini tanımlar; Calot üçgeninin sınırları değildir. Bu olguda "Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır." ve "Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır." ifadeleri tanısal karar açısından Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Mide küçük kurvaturu, pylorus ve duodenum birinci kısmı: Mide küçük kurvaturu, pylorus ve duodenum birinci kısmı üst gastrointestinal anatomiyle ilişkilidir; kolesistektomi güvenli diseksiyonu oluşturmaz. Bu olguda "Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır." ve "Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır." ifadeleri tanısal karar açısından Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Arteria mesenterica superior, vena splenica ve pankreas boynu: Arteria mesenterica superior, vena splenica ve pankreas boynu pankreatik-vasküler komşuluklarla ilişkilidir; Calot üçgeninin parçası değildir. Bu olguda "Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır." ve "Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır." ifadeleri tanısal karar açısından Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Ligamentum teres hepatis, ligamentum falciforme ve umbilikal ven kalıntısı: Ligamentum teres hepatis, ligamentum falciforme ve umbilikal ven kalıntısı karaciğer ön duvar bağlarıyla ilişkilidir; safra kesesi boynu üçgenini tanımlamaz. Bu olguda "Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır." ve "Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır." ifadeleri tanısal karar açısından Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Laparoskopik kolesistektomi sırasında anatomik alan olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır." ve "Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır." birlikte okunduğunda Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı seçeneği öne çıkar; "Cerrahi güvenlik için ductus cysticus ve ilişkili hepatik kanal anatomisinin tanımlanması gerekir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kolesistektomide Calot üçgeni, ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı ile sınırlı cerrahi alandır. Arteria cystica genellikle bu bölgede tanımlanır; yanlış yapıların kesilmesini önlemek için kritik güvenlik görüşü sağlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır.", "Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır." ve "Cerrahi güvenlik için ductus cysticus ve ilişkili hepatik kanal anatomisinin tanımlanması gerekir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ve karaciğerin inferior kenarı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta laparoskopik kolesistektomiye alınmıştır.

Kanıt 2: Diseksiyon safra kesesi boynu ve hepatobiliyer yapıların çevresinde yapılmaktadır.

Kanıt 3: Cerrahi güvenlik için ductus cysticus ve ilişkili hepatik kanal anatomisinin tanımlanması gerekir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Calot üçgeni kolesistektomide arteria cystica ve ductus cysticusun güvenli tanımlanması için kritik alandır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 201: v185-new-201-kol-uzerine-dusme-sonrasi-el-bilegi-dusuklugu

Başlık: Kol üzerine düşme sonrası el bileği düşüklüğü

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Humerus shaft kırığında nervus radialis hasarını düşük el bulgusuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, düşme sonrası sağ kol ağrısı ve el bileğini kaldıramama nedeniyle başvuruyor. Merdivenden düşerken sağ kolunun üzerine çarptığını, olaydan sonra el bileğini ve parmaklarını yukarı kaldıramadığını belirtiyor. Daha önce üst ekstremitte nörolojik yakınması yoktur.

Demografi: 36 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ kol orta kısmında hassasiyet ve deformite vardır.
- El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıftır.
- El sırtında birinci dorsal aralıkta duyu azalması saptanır.
- Parmak fleksiyonu korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Humerus grafisi

Etiket: Humerus grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Humerus orta shaft düzeyinde kırık izlendi. | Klinik anlam: Spiral oluk komşuluğundaki sinir hasarı açısından risklidir. | Sonuç yorumu: Spiral oluk komşuluğundaki sinir hasarı açısından risklidir. | Sonuç başlığı: Humerus grafisi | Sonuç özeti: Humerus orta shaft düzeyinde kırık izlendi. | Yorum: Spiral oluk komşuluğundaki sinir hasarı açısından risklidir. | Satırlar: Humerus grafisi / Humerus orta shaft düzeyinde kırık izlendi. // Spiral oluk komşuluğundaki sinir hasarı açısından risklidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-106 | Başlık: Humerus grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Humerus orta shaft düzeyinde kırık izlendi. | Klinik anlam: Spiral oluk komşuluğundaki sinir hasarı açısından risklidir. | URL: https://iukbtikzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/106_106-humerus-orta-shaft-kirigi-direkt-grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/106_106-humerus-orta-shaft-kirigi-direkt-grafi.webp | Alt text: Humerus grafisi - Humerus orta shaft düzeyinde kırık izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma olasılığı en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus radialis
B) Nervus medianus
C) Nervus ulnaris
D) Nervus axillaris
E) Nervus musculocutaneus

Doğru Cevap: Nervus radialis

- A) Nervus radialis: Nervus radialis humerus spiral oluğunda seyreder ve el bileği-parmak ekstansiyonu ile birinci dorsal aralık duyunu sağlar. Vakadaki "Kırık humerus orta shaft düzeyindedir." ve "El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Nervus medianus: Nervus medianus tenar kaslar ve lateral avuç duyusuyla ilişkilidir; düşük el paternini en iyi açıklamaz. Bu olguda "Kırık humerus orta shaft düzeyindedir." ve "El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus radialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nervus ulnaris: Nervus ulnaris interosseöz kaslar ve ulnar el duyusuyla ilişkilidir; el bileği ekstansiyon kaybı tipik değildir. Bu olguda "Kırık humerus orta shaft düzeyindedir." ve "El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus radialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nervus axillaris: Vakadaki kırık humerus orta shaft düzeyindedir ve el bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır. Bu olguda "Kırık humerus orta shaft düzeyindedir." ve "El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus radialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus musculocutaneus: Nervus musculocutaneus dirsek fleksiyonu ve lateral ön kol duyusuyla ilişkilidir; bu Vakadaki düşük el bulgusunu açıklamaz. Bu olguda "Kırık humerus orta shaft düzeyindedir." ve "El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır." ipuçları tanısız karar açısından Nervus radialis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kol üzerine düşme sonrası el bileği düşüklüğü olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Kırık humerus orta shaft düzeyindedir." ve "El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır." birlikte okunduğunda Nervus radialis seçeneği öne çıkar; "El sırtında birinci dorsal aralıkta duyu azalması vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Humerus orta shaft kırığı spiral olukta seyreden nervus radialis için risklidir. El bileği ve parmak ekstansiyon kaybı ile birinci dorsal aralıkta duyu azalması radial sinir hasarını destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Kırık humerus orta shaft düzeyindedir.", "El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır." ve "El sırtında birinci dorsal aralıkta duyu azalması vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus radialis en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Kırık humerus orta shaft düzeyindedir.

Kanıt 2: El bileği ve parmak ekstansiyonu belirgin zayıflamıştır.

Kanıt 3: El sırtında birinci dorsal aralıkta duyu azalması vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Humerus shaft kırığında düşük el bulgusu nervus radialis hasarını düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 202: v185-new-202-diz-dis-yan-travmasi-sonrasi-dusuk-ayak

Başlık: Diz dış yan travması sonrası düşük ayak

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Fibula boynu travmasında nervus fibularis communis hasarını düşük ayak bulgusuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, dizin dış yanına darbe sonrası ayağını yukarı kaldıramama nedeniyle başvuruyor. Futbol sırasında sağ dizinin dış yanına direkt darbe aldığını, ardından yürürken ayağının takıldığını ve ayak sırtında uyuşma hissettiğini belirtmektedir.

Demografi: 27 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ ayakta dorsifleksiyon ve eversiyon zayıftır.
- Yürümede steppage paterni izlenir.
- Ayak sırtında duyu azalması vardır.
- Plantar fleksiyon korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Diz grafisi

Etiket: Diz grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Fibula boynu çevresinde travmatik hassasiyetle uyumlu bulgular izlendi. | Klinik anlam: Sinirin yüzeyel seyrettiği bölgeyle ilişkilidir. | Sonuç yorumu: Sinirin yüzeyel seyrettiği bölgeyle ilişkilidir. | Sonuç başlığı: Diz grafisi | Sonuç özeti: Fibula boynu çevresinde travmatik hassasiyetle uyumlu bulgular izlendi. | Yorum: Sinirin yüzeyel seyrettiği bölgeyle ilişkilidir. | Satırlar: Diz grafisi / Fibula boynu çevresinde travmatik hassasiyetle uyumlu bulgular izlendi. // Sinirin yüzeyel seyrettiği bölgeyle ilişkilidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-107 | Başlık: Diz grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Fibula boynu çevresinde travmatik hassasiyetle uyumlu bulgular izlendi. | Klinik anlam: Sinirin yüzeyel seyrettiği bölgeyle ilişkilidir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/107_107-fibula-boynu-travmasi-diz-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/107_107-fibula-boynu-travmasi-diz-grafisi.webp | Alt text: Diz grafisi - Fibula boynu çevresinde travmatik hassasiyetle uyumlu bulgular izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanma olasılığı en yüksek sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus tibialis
B) Nervus fibularis communis
C) Nervus femoralis
D) Nervus obturatorius
E) Nervus gluteus inferior

Doğru Cevap: Nervus fibularis communis

- A) Nervus tibialis: Nervus tibialis plantar fleksiyon ve ayak tabanı duyusuyla ilişkilidir; bu hastada plantar fleksiyon korunmuştur. Bu olguda “Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.” ve “Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus fibularis communis seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Nervus fibularis communis: Nervus fibularis communis fibula boynunda yüzeyel seyrederek ve dorsifleksiyon-eversiyon kaybı ile düşük ayak yapar. Vakadaki “Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.” ve “Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- C) Nervus femoralis: Nervus femoralis diz ekstansiyonu ve anterior uyluk duyusuyla ilişkilidir; ayak sırtı duyusunu açıklamaz. Bu olguda “Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.” ve “Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus fibularis communis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nervus obturatorius: Vakadaki Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir ve Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır. Bu olguda “Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.” ve “Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus fibularis communis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus gluteus inferior: Vakadaki Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir ve Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır. Bu olguda “Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.” ve “Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus fibularis communis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Diz dış yan travması sonrası düşük ayak olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.” ve “Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.” birlikte okunduğunda Nervus fibularis communis seçeneği öne çıkar; “Ayak sırtında duyu azalması vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Fibula boynu çevresinde yüzeyel seyreden nervus fibularis communis travmaya açıktır. Dorsifleksiyon ve eversiyon kaybı, steppage yürüyüş ve ayak sırtı duyusunun azalması bu sinir hasarıyla uyumludur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.”, “Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.” ve “Ayak sırtında duyu azalması vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus fibularis communis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Travma dizin dış yanında fibula boynu komşuluğunda gelişmiştir.

Kanıt 2: Ayak dorsifleksiyonu ve eversiyonu zayıflamıştır.

Kanıt 3: Ayak sırtında duyu azalması vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Fibula boynu travmasında düşük ayak en tipik olarak nervus fibularis communis hasarıyla ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 203: v185-new-203-kasik-ameliyati-sonrasi-uyusma

Başlık: Kasık ameliyatı sonrası uyusma

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomi yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: İnguinal herni onarımı sonrası nervus ilioinguinalis hasarını duyu alanıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, inguinal herni ameliyatından sonra kasık ve skrotum üst kısmında uyusma nedeniyle başvuruyor. İki hafta önce sağ açık inguinal herni onarımı geçirdiğini, ameliyat sonrası ağrısının azaldığını ancak sağ kasık ve skrotum kökü çevresinde hissizlik fark ettiğini belirtmektedir.

Demografi: 48 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ inguinal insizyon iyileşmektedir.
- Sağ kasık bölgesi, penis kökü ve skrotum ön-üst kısmında hafif duyu azalması vardır.
- Uyluk adduksiyonu ve diz ekstansiyonu normaldir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada etkilenmesi en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus ilioinguinalis
- B) Nervus obturatorius
- C) Nervus femoralis
- D) Nervus ischiadicus
- E) Nervus pudendus

Doğru Cevap: Nervus ilioinguinalis

A) Nervus ilioinguinalis: Nervus ilioinguinalis inguinal kanal bölgesinden geçer ve anterior skrotal-kasık duyusunu sağladığı için bu tabloyu açıklar. Vakadaki “Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.” ve “Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleşenir.

B) Nervus obturatorius: Nervus obturatorius uyluk adduktorlarını ve medial uyluk duyusunu etkiler; anterior skrotal duyuyu sağlamaz. Bu olguda “Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.” ve “Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Nervus ilioinguinalis seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus femoralis: Nervus femoralis diz ekstansiyonu ve anterior uyluk duyusuyla ilişkilidir; bu hastada motor bulgu yoktur. Bu olguda “Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.” ve “Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Nervus ilioinguinalis seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nervus ischiadicus: Nervus ischiadicus arka uyluk ve bacak-ayak motor fonksiyonlarını etkiler; kasık cerrahisi sonrası lokal duyu kaybını açıklamaz. Bu olguda “Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.” ve “Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Nervus ilioinguinalis seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus pudendus: Nervus pudendus perine ve dış genital derin duyusuyla ilişkilidir; inguinal kanal cerrahisindeki tipik anterior skrotal duyu siniri değildir. Bu olguda “Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.” ve “Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Nervus ilioinguinalis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kasık ameliyatı sonrası uyusma olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.” ve “Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.” birlikte okunduğunda Nervus ilioinguinalis seçeneği öne çıkar; “Uyluk adduksiyonu ve diz ekstansiyonu korunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nervus ilioinguinalis inguinal kanal bölgesinde seyrederek ve açık inguinal herni onarımında etkilenebilir. Kasık, penis kökü ve skrotum ön-üst kısmındaki duyu azalması bu sinirin duyu alanıyla uyumludur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.”, “Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.” ve “Uyluk adduksiyonu ve diz ekstansiyonu korunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus ilioinguinalis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Duyu kaybı açık inguinal herni onarımı sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Kasık bölgesi ve skrotum ön-üst kısmında his azalması vardır.

Kanıt 3: Uyluk adduksiyonu ve diz ekstansiyonu korunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: İnguinal kanal cerrahisinden sonra kasık ve anterior skrotal duyu kaybında nervus ilioinguinalis düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 204: v185-new-204-asiri-susama-ve-seyrek-idrar-yogunlasmasi

Başlık: Aşırı susama ve seyrek idrar yoğunlaşması

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Santral diabetes insipidusta ADH eksikliğini su kısıtlama testi ve desmopressin yanıtıyla açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, aşırı su içme ve çok miktarda idrar yapma nedeniyle başvuruyor. Son aylarda günde 7-8 litre su içtiğini ve gece sık idrara kalktığını belirtmektedir. Yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir. Diyabet öyküsü yoktur.

Demografi: 32 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/66 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,88

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Mukozalar hafif kurudur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek-normal saptandı. | Klinik anlam: Serbest su kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Serbest su kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Yüksek-normal saptandı. | Yorum: Serbest su kaybını destekler. | Satırlar: Serum sodyum / 146 mmol/L / 135-145 mmol/L / Serbest su kaybını destekler.

Tetkik 2: İdrar osmolalitesi

Etiket: İdrar osmolalitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: İdrarın yoğunlaştırılmadığını gösterir. | Sonuç yorumu: İdrarın yoğunlaştırılmadığını gösterir. | Sonuç başlığı: İdrar osmolalitesi | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: İdrarın yoğunlaştırılmadığını gösterir. | Satırlar: İdrar osmolalitesi / 110 mOsm/kg / 300-900 mOsm/kg / İdrarın yoğunlaştırılmadığını gösterir.

Tetkik 3: Desmopressin sonrası idrar osmolalitesi

Etiket: Desmopressin sonrası idrar osmolalitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin arttı. | Klinik anlam: ADH eksikliği lehinedir. | Sonuç yorumu: ADH eksikliği lehinedir. | Sonuç başlığı: Desmopressin sonrası idrar osmolalitesi | Sonuç özeti: Belirgin arttı. | Yorum: ADH eksikliği lehinedir. | Satırlar: Desmopressin sonrası idrar osmolalitesi / 560 mOsm/kg / ADH eksikliği lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki temel fizyolojik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği
B) Toplayıcı kanalın antidiüretik hormona yanıtısızlığı
C) Aldosteron fazlalığına bağlı sodyum kaybı
D) İnsülin fazlalığına bağlı ozmotik diürez
E) Atriyal natriüretik peptid eksikliğine bağlı su tutulumu

Doğru Cevap: Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği

- A) Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği: Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği desmopressinle düzelebilen düşük idrar osmolalitesi paternini açıklar. Vakadaki "Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir." ve "İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Toplayıcı kanalın antidiüretik hormona yanıtısızlığı: Toplayıcı kanalın antidiüretik hormona yanıtısızlığı nefrojenik diabetes insipidusu düşündürür ve desmopressin yanıtı belirgin olmaz. Bu olguda "Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir." ve "İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Aldosteron fazlalığına bağlı sodyum kaybı: Vakadaki Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir ve İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır. Bu olguda "Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir." ve "İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) İnsülin fazlalığına bağlı ozmotik diürez: Vakadaki Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir ve İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır. Bu olguda "Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir." ve "İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Atriyal natriüretik peptid eksikliğine bağlı su tutulumu: Atriyal natriüretik peptid eksikliği bu hastadaki seyreltilmiş idrar ve desmopressin yanıtının temel nedeni değildir. Bu olguda "Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir." ve "İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Aşırı susama ve seyrek idrar yoğunlaşması olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir." ve "İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır." birlikte okunduğunda Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği seçeneği öne çıkar; "Desmopressin sonrası idrar osmolalitesi belirgin artmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipofiz cerrahisi sonrası poliüri, düşük idrar osmolalitesi ve desmopressinle idrar osmolalitesinin belirgin artması santral diabetes insipidusu gösterir. Temel sorun antidiüretik hormon eksikliğidir; böbrek yanıtı korunduğu için desmopressine yanıt alınır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir.", "İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır." ve "Desmopressin sonrası idrar osmolalitesi belirgin artmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Posterior hipofiz kaynaklı antidiüretik hormon eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta yakın zamanda hipofiz cerrahisi geçirmiştir.

Kanıt 2: İdrar osmolalitesi düşük saptanmıştır.

Kanıt 3: Desmopressin sonrası idrar osmolalitesi belirgin artmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Santral diabetes insipidusta desmopressin yanıtı vardır; nefrojenik tipte yanıt yayıftır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 205: v185-new-205-kronik-karbondioksit-retansiyonu

Başlık: Kronik karbondioksit retansiyonu

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Kronik solunumsal asidozda renal kompanzasyonun yönünü açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, uzun süredir devam eden nefes darlığı ve kronik karbondioksit yüksekliği nedeniyle değerlendiriliyor. Uzun yıllar sigara kullandığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı olduğu öğreniliyor. Son haftalarda belirgin akut kötüleşme olmadan efor kapasitesi azalmıştır.

Demografi: 62 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %90% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,32 (yüksek)

Fizik Muayene

- Fıçı göğüs görünümü vardır.
- Bilinci açıktır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Kronik solunumsal asidozla uyumlu patern saptandı. | Klinik anlam: Renal kompanzasyon pH değerini sınırlı düzeltmiştir. | Sonuç yorumu: Renal kompanzasyon pH değerini sınırlı düzeltmiştir. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Kronik solunumsal asidozla uyumlu patern saptandı. | Yorum: Renal kompanzasyon pH değerini sınırlı düzeltmiştir. | Satırlar: Arter kan gazı / pH 7.36, PaCO₂ 58, HCO₃ 32 mmHg ve mmol/L / pH 7.35-7.45, PaCO₂ 35-45 mmHg, HCO₃ 22-26 mmol/L / Renal kompanzasyon pH değerini sınırlı düzeltmiştir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada pH değerinin normale yakın kalmasını sağlayan temel kompanzasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması
B) Böbrekte bikarbonat atılımının artması
C) Akciğerde karbondioksit üretiminin tamamen durması
D) Eritrositlerde oksijen bağlanmasının geri dönüşümsüz artması
E) Toplayıcı kanalda su geçirgenliğinin tamamen kaybolması

Doğru Cevap: Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması

- A) Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması: Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması kronik solunumsal asidozda doğru kompanzasyondur. Vakadaki "PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır." ve "Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Böbrekte bikarbonat atılımının artması: Vakadaki PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır ve Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir. Bu olguda "PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır." ve "Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir." ipuçları klinik karar açısından Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Akciğerde karbondioksit üretiminin tamamen durması: Vakadaki PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır ve Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir. Bu olguda "PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır." ve "Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir." ipuçları klinik karar açısından Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Eritrositlerde oksijen bağlanmasının geri dönüşümsüz artması: Vakadaki PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır ve Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir. Bu olguda "PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır." ve "Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir." ipuçları klinik karar açısından Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Toplayıcı kanalda su geçirgenliğinin tamamen kaybolması: Toplayıcı kanal su geçirgenliğinin kaybı su dengesini etkiler; kronik karbondioksit retansiyonunun temel kompanzasyonu değildir. Bu olguda "PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır." ve "Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir." ipuçları klinik karar açısından Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik karbondioksit retansiyonu olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır." ve "Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir." birlikte okunduğunda Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması seçeneği öne çıkar; "pH ağır asidoz yerine normale yakın ölçülmüştür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik karbondioksit retansiyonu primer solunumsal asidoz oluşturur. Böbrekler hidrojen iyonu atılımını ve bikarbonat geri kazanımı-yeni bikarbonat üretimini artırarak pH değerini kısmen normale yaklaştırır. Bu olguda kararın temel ayırımı, "PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır.", "Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir." ve "pH ağır asidoz yerine normale yakın ölçülmüştür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Böbrekte bikarbonat geri emilimi ve yeni bikarbonat üretiminin artması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: PaCO₂ kronik olarak yüksek saptanmıştır.

Kanıt 2: Bikarbonat düzeyi normalin üzerindedir.

Kanıt 3: pH ağır asidoz yerine normale yakın ölçülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Kronik solunumsal asidozda renal kompanzasyon bikarbonat artışıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 206: v185-new-206-ani-kan-basinci-yukselmesi

Başlık: Ani kan basıncı yükselmesi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Baroreseptör refleksinde ani hipertansiyona verilen kalp hızı yanıtını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Deneyisel simülasyonda arter basıncı kısa süreli yükseldiğinde beklenen otonom yanıt tartışılıyor. Bilinen kardiyovasküler hastalığı ve düzenli ilaç kullanımı yoktur. Değerlendirme fizyolojik refleks mekanizmayı öğretmek amacıyla yapılmaktadır.

Demografi: 45 yaşında sağlıklı gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 116/72 mmHg | Nabız: 74/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,64

Fizik Muayene

- Dinlenme muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Simülasyon bulgusu

Etiket: Simülasyon bulgusu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Karotis sinüs basıncı akut olarak artırıldı. | Klinik anlam: Baroreseptör ateşlemesini artıran durumdur. | Sonuç yorumu: Baroreseptör ateşlemesini artıran durumdur. | Sonuç başlığı: Simülasyon bulgusu | Sonuç özeti: Karotis sinüs basıncı akut olarak artırıldı. | Yorum: Baroreseptör ateşlemesini artıran durumdur. | Satırlar: Simülasyon bulgusu / Karotis sinüs basıncı akut olarak artırıldı. // Baroreseptör ateşlemesini artıran durumdur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Karotis sinüs basıncı akut arttığında beklenen refleks yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma
- B) Sempatik aktivite artışı ve kalp hızında artma
- C) Vagal tonus azalması ve taşikardi
- D) Renin salınımında ani artışla hipertansiyonun sürdürülmesi
- E) Aldosteron salınımında ani artışla bradikardi oluşması

Doğru Cevap: Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma

- A) Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma: Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma yüksek baroreseptör ateşlemesine verilen doğru refleks yanıtıdır. Vakadaki "Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır." ve "Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Sempatik aktivite artışı ve kalp hızında artma: Vakadaki Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır ve Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır. Bu olguda "Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır." ve "Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır." ipuçları klinik karar açısından Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Vagal tonus azalması ve taşikardi: Vagal tonusun azalması taşikardi yapar ve yüksek karotis sinüs basıncını dengeleyici yönde değildir. Bu olguda "Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır." ve "Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır." ipuçları klinik karar açısından Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Renin salınımında ani artışla hipertansiyonun sürdürülmesi: Renin salınımı daha yavaş hacim-basınç düzenlemesidir; akut barorefleksin temel yanıtı değildir. Bu olguda "Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır." ve "Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır." ipuçları klinik karar açısından Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Aldosteron salınımında ani artışla bradikardi oluşması: Aldosteron salınımı akut bradikardi mekanizması değildir ve baroreseptör refleksin doğrudan çıktısını açıklamaz. Bu olguda "Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır." ve "Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır." ipuçları klinik karar açısından Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani kan basıncı yükselmesi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır." ve "Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır." birlikte okunduğunda Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma seçeneği öne çıkar; "Yanıt kısa süreli otonom refleks düzenlemeye yöneliktir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Arter basıncı arttığında karotis sinüs ve aortik ark baroreseptörlerinin ateşlemesi artar. Medüller merkezler parasempatik çıkışı artırıp sempatik çıkışı azaltır; sonuçta kalp hızı ve damar tonusu düşerek basınç dengelenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır.", "Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır." ve "Yanıt kısa süreli otonom refleks düzenlemeye yöneliktir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Parasempatik aktivite artışı ve kalp hızında azalma en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Simülasyonda karotis sinüs basıncı akut artırılmıştır.

Kanıt 2: Bu durum baroreseptör ateşlemesini artırır.

Kanıt 3: Yanıt kısa süreli otonom refleks düzenlemeye yöneliktir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Akut hipertansiyonda baroreseptör ateşlemesi artar ve refleks bradikardi gelişir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 207: v185-new-207-agrisiz-alt-gastrointestinal-kanama

Başlık: Ağrısız alt gastrointestinal kanama

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Meckel divertikülünü omfalomezenterik kanal kalıntısıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, tekrarlayan ağrısız parlak kırmızı rektal kanama nedeniyle getiriliyor. Ailesi son bir ayda birkaç kez dışkıyla birlikte kan gördüklerini, çocuğun belirgin karın ağrısı veya ateş tariflemediğini belirtmektedir. Daha önce benzer yakınması yoktur.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Batın yumuşak ve hassasiyetsizdir.
- Rektal muayenede aktif kitle saptanmaz.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetik 1: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi

Etiket: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum izlendi. | Klinik anlam: Meckel divertikülü lehine bulgudur. | Sonuç yorumu: Meckel divertikülü lehine bulgudur. | Sonuç başlığı: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi | Sonuç özeti: Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum izlendi. | Yorum: Meckel divertikülü lehine bulgudur. | Satırlar: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi / Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum izlendi. // Meckel divertikülü lehine bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-108 | Başlık: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum izlendi. | Klinik anlam: Meckel divertikülü lehine bulgudur. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/108_108-meckel-divertikulu-sintigrafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/108_108-meckel-divertikulu-sintigrafi.webp | Alt text: Teknesyum-99m perteknetat sintigrafisi - Sağ alt kadranda ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu lezyonun embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Omfalomezenterik kanal kalıntısı
B) Ürakuş kalıntısı
C) Tiroglossal kanal kalıntısı
D) Nöral tüp kapanma kusuru
E) Pleuroperitoneal membran kapanma kusuru

Doğru Cevap: Omfalomezenterik kanal kalıntısı

A) Omfalomezenterik kanal kalıntısı: Omfalomezenterik kanal kalıntısı Meckel divertikülünün embriyolojik kökenidir ve ağrısız kanamayı açıklayabilir. Vakadaki “Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.” ve “Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Ürakuş kalıntısı: Ürakuş kalıntısı umbilikus ile mesane arasındaki bağlantı anomalileriyle ilişkilidir; ileal divertikül oluşturmaz. Bu olguda “Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.” ve “Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.” ipuçları klinik karar açısından Omfalomezenterik kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Tiroglossal kanal kalıntısı: Tiroglossal kanal kalıntısı orta hat boyun kisti yapar; alt gastrointestinal kanamayla ilişkili değildir. Bu olguda “Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.” ve “Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.” ipuçları klinik karar açısından Omfalomezenterik kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Nöral tüp kapanma kusuru: Nöral tüp kapanma kusuru merkezi sinir sistemi ve vertebral defektlerle ilişkilidir; Meckel divertikülü mekanizması değildir. Bu olguda “Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.” ve “Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.” ipuçları klinik karar açısından Omfalomezenterik kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Pleuroperitoneal membran kapanma kusuru: Pleuroperitoneal membran kapanma kusuru konjenital diyafram hernisiyle ilişkilidir; ileal ektopik mukoza açıklamaz. Bu olguda “Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.” ve “Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.” ipuçları klinik karar açısından Omfalomezenterik kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ağrısız alt gastrointestinal kanama olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.” ve “Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.” birlikte okunduğunda Omfalomezenterik kanal kalıntısı seçeneği öne çıkar; “Lezyon sağ alt kadrana-ileal bölgeyle ilişkilidir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çocukta ağrısız alt gastrointestinal kanama ve ektopik gastrik mukoza tutulumu Meckel divertikülünü düşündürür. Meckel divertikülü vitellin kanal olarak da bilinen omfalomezenterik kanalın persiste kalıntısıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.”, “Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.” ve “Lezyon sağ alt kadrana-ileal bölgeyle ilişkilidir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Omfalomezenterik kanal kalıntısı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanama ağrısız ve alt gastrointestinal sistem kaynaklıdır.

Kanıt 2: Sintigrafide ektopik gastrik mukoza ile uyumlu tutulum vardır.

Kanıt 3: Lezyon sağ alt kadrana-ileal bölgeyle ilişkilidir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Meckel divertikülü omfalomezenterik kanal kalıntısıdır ve ektopik gastrik mukoza kanama yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 208: v185-new-208-yenidoganda-hipokalsemi-ve-enfeksiyon-egilimi

Başlık: Yenidoğanda hipokalsemi ve enfeksiyon eğilimi

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusurunu DiGeorge sendromuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, tekrarlayan enfeksiyonlar ve hipokalsemik kasılma öyküsü nedeniyle getiriliyor. Doğumdan sonra hipokalsemik nöbet geçirdiği, son haftalarda tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları yaşadığı öğreniliyor. Aile, bebeğin yüz görünümünde farklılık olduğunu belirtmektedir.

Demografi: 2 aylık erkek bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Yüzde düşük kulak yerleşimi ve mikrognati izlenir.
- Kardiyak oskültasyonda üfürüm duyulur.
- Lenfoid doku belirgin az gelişmiş görünmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kalsiyum

Etiket: Serum kalsiyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Paratiroid hipoplazisini düşündürür. | Sonuç yorumu: Paratiroid hipoplazisini düşündürür. | Sonuç başlığı: Serum kalsiyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Paratiroid hipoplazisini düşündürür. | Satırlar: Serum kalsiyum / 7.1 mg/dL / 8.5-10.5 mg/dL / Paratiroid hipoplazisini düşündürür.

Tetkik 2: T lenfosit sayısı

Etiket: T lenfosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Timus hipoplazisini destekler. | Sonuç yorumu: Timus hipoplazisini destekler. | Sonuç başlığı: T lenfosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Timus hipoplazisini destekler. | Satırlar: T lenfosit sayısı / Düşük saptandı. // Timus hipoplazisini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablonun temel embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru
- B) Birinci faringeal arkın aşırı gelişimi
- C) Omfalomezenterik kanalın persiste kalması
- D) Kaudal nöroporun kapanmaması
- E) Allantoisin mesaneye dönüşmemesi

Doğru Cevap: Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru

- A) Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru: Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru timus-paratiroid hipoplazisiyle hipokalsemi ve T hücre yetmezliğini açıklar. Vakadaki "Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır." ve "T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Birinci faringeal arkın aşırı gelişimi: Birinci faringeal ark yüz ve çene yapılarını etkiler ancak timus-paratiroid hipoplazisinin temel mekanizması değildir. Bu olguda "Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır." ve "T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Omfalomezenterik kanalın persiste kalması: Omfalomezenterik kanalın persiste kalması Meckel divertikülü yapar; immün yetmezlik ve hipokalsemiyle ilişkili değildir. Bu olguda "Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır." ve "T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Kaudal nöroporun kapanmaması: Vakadaki Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır ve T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır. Bu olguda "Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır." ve "T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Allantoisin mesaneye dönüşmemesi: Allantois-ürakus anomalileri umbilikal idrar kaçağı gibi durumlarla ilişkilidir; DiGeorge bulgularını açıklamaz. Bu olguda "Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır." ve "T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda hipokalsemi ve enfeksiyon eğilimi olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır." ve "T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır." birlikte okunduğunda Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru seçeneği öne çıkar; "Yüz anomalileri ve kardiyak üfürüm eşlik etmektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipokalsemi, T hücre azlığı, tekrarlayan enfeksiyon, konotrunkal kalp anomalisi ve yüz bulguları DiGeorge sendromunu düşündürür. Temel embriyolojik sorun üçüncü ve dördüncü faringeal poşların gelişim kusurudur; timus ve paratiroid hipoplazisi gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır.", "T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır." ve "Yüz anomalileri ve kardiyak üfürüm eşlik etmektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte hipokalsemik nöbet öyküsü vardır.

Kanıt 2: T lenfosit sayısı düşük saptanmıştır.

Kanıt 3: Yüz anomalileri ve kardiyak üfürüm eşlik etmektedir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: DiGeorge sendromunda üçüncü ve dördüncü faringeal poş gelişim kusuru timus ve paratiroid hipoplazisi yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 209: v185-new-209-premature-bebekte-solunum-sikintisi

Başlık: Prematüre bebekte solunum sıkıntısı

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik veriyi hedeflenen karar noktasıyla eşleştirme.

Learning Target: Tip II pnömositlerin surfaktan üretimini alveoler stabiliteyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan kısa süre sonra inleme, takipne ve oksijen ihtiyacı nedeniyle izleniyor. Antenatal steroid uygulanmadan erken doğum gerçekleştiği öğreniliyor. Doğumdan sonra solunum sıkıntısı giderek artmıştır.

Demografi: 31 haftalık prematüre erkek bebek | Setting: Yenidoğan yoğun bakım

Vital Bulgular

Kan basıncı: 62/38 mmHg | Nabız: 158/dk | Solunum: 72/dk | SpO₂: %88% | Ateş: 36.5°C | Şok indeksi: 2,55 (yüksek)

Fizik Muayene

- Burun kanadı solunumu, interkostal çekilme ve inleme vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlendi. | Klinik anlam: Respiratuvar distres sendromunu destekler. | Sonuç yorumu: Respiratuvar distres sendromunu destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlendi. | Yorum: Respiratuvar distres sendromunu destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlendi. / / Respiratuvar distres sendromunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-109 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlendi. | Klinik anlam: Respiratuvar distres sendromunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/109_109-yenidogan-respiratuvar-distres-sendromu-akciger-grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/109_109-yenidogan-respiratuvar-distres-sendromu-akciger-grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Bilateral retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramları izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablonun temelinde yetersiz fonksiyonu bulunan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tip II pnömosit
- B) Tip I pnömosit
- C) Kupffer hücresi
- D) Goblet hücresi
- E) Paneth hücresi

Doğru Cevap: Tip II pnömosit

- A) Tip II pnömosit: Tip II pnömosit surfaktan üreterek alveollerin açık kalmasını sağlar ve bu prematüre bebekte yetersizliği temel sorundur. Vakadaki “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Antenatal steroid uygulanmamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Tip I pnömosit: Tip I pnömosit gaz değişim yüzeyinin büyük kısmını oluşturur ancak surfaktanın ana üreticisi değildir. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Antenatal steroid uygulanmamıştır.” ipuçları klinik karar açısından Tip II pnömosit seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Kupffer hücresi: Vakadaki Bebek prematüre doğmuştur ve Antenatal steroid uygulanmamıştır. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Antenatal steroid uygulanmamıştır.” ipuçları klinik karar açısından Tip II pnömosit seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Goblet hücresi: Vakadaki Bebek prematüre doğmuştur ve Antenatal steroid uygulanmamıştır. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Antenatal steroid uygulanmamıştır.” ipuçları klinik karar açısından Tip II pnömosit seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Paneth hücresi: Paneth hücresi intestinal kriptlerde antimikrobiyal ürünler salgılar; akciğer surfaktanı ile ilişkili değildir. Bu olguda “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Antenatal steroid uygulanmamıştır.” ipuçları klinik karar açısından Tip II pnömosit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Prematüre bebekte solunum sıkıntısı olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Bebek prematüre doğmuştur.” ve “Antenatal steroid uygulanmamıştır.” birlikte okunduğunda Tip II pnömosit seçeneği öne çıkar; “Grafide respiratuvar distres sendromuyla uyumlu bulgular vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Prematüre bebekte respiratuvar distres sendromunun temel nedeni surfaktan eksikliğidir. Surfaktan alveoler yüzey gerilimini azaltır ve tip II pnömositler tarafından üretilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek prematüre doğmuştur.”, “Antenatal steroid uygulanmamıştır.” ve “Grafide respiratuvar distres sendromuyla uyumlu bulgular vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Tip II pnömosit en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebek prematüre doğmuştur.

Kanıt 2: Antenatal steroid uygulanmamıştır.

Kanıt 3: Grafide respiratuvar distres sendromuyla uyumlu bulgular vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Tip II pnömosit surfaktan üretir; surfaktan eksikliği prematüre bebekte alveoler kollapsa neden olur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 210: v185-new-210-aclik-sonrasi-bilinc-degisikligi

Başlık: Açlık sonrası bilinç değişikliği

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: MCAD eksikliğinde açlık sonrası hipoketotik hipoglisemi mekanizmasını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, viral enfeksiyon sırasında beslenememe sonrası gelişen letarji ve nöbet nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun bir gündür az beslendiğini ve sabah uyandırmakta zorlandıklarını belirtir. Daha önce uzun açlık sonrası benzer halsizlik atakları olduğu öğreniliyor.

Demografi: 18 aylık kız çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/52 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,53 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk letarjik ve hipotoniktir.
- Hepatomegali belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Açlık hipoglisemisini gösterir. | Sonuç yorumu: Açlık hipoglisemisini gösterir. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Açlık hipoglisemisini gösterir. | Satırlar: Kan glukozu / 38 mg/dL / 70-100 mg/dL / Açlık hipoglisemisini gösterir.

Tetkik 2: Serum ketonu

Etiket: Serum ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Beklenenden düşük saptandı. | Klinik anlam: Hipoketotik hipoglisemi paternini destekler. | Sonuç yorumu: Hipoketotik hipoglisemi paternini destekler. | Sonuç başlığı: Serum ketonu | Sonuç özeti: Beklenenden düşük saptandı. | Yorum: Hipoketotik hipoglisemi paternini destekler. | Satırlar: Serum ketonu / Beklenenden düşük saptandı. / Hipoketotik hipoglisemi paternini destekler.

Tetkik 3: Açıl-karnitin profili

Etiket: Açıl-karnitin profili | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Orta zincirli açıl-karnitinlerde artış saptandı. | Klinik anlam: Orta zincir yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Orta zincir yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Açıl-karnitin profili | Sonuç özeti: Orta zincirli açıl-karnitinlerde artış saptandı. | Yorum: Orta zincir yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler. | Satırlar: Açıl-karnitin profili / Orta zincirli açıl-karnitinlerde artış saptandı. / Orta zincir yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki temel biyokimyasal defekt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği
B) Glukoz-6-fosfataz eksikliği
C) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
D) Galaktokinaz eksikliği
E) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği

Doğru Cevap: Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği

- A) Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği: Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği açlık sonrası hipoketotik hipoglisemi ve orta zincir açıl-karnitin artışı açıklar. Vakadaki "Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Vakadaki Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir ve Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür. Bu olguda "Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür." ipuçları klinik karar açısından Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüri yapar ve hipoketotik hipoglisemi paternini açıklamaz. Bu olguda "Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür." ipuçları klinik karar açısından Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Galaktokinaz eksikliği: Vakadaki Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir ve Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür. Bu olguda "Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür." ipuçları klinik karar açısından Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği: Hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği Lesch-Nyhan sendromuna yol açar; yağ asidi oksidasyon bozukluğu değildir. Bu olguda "Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür." ipuçları klinik karar açısından Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlık sonrası bilinç değişikliği olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir." ve "Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür." birlikte okunduğunda Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği seçeneği öne çıkar; "Açıl-karnitin profilinde orta zincirli türler artmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Açlık ve enfeksiyonla tetiklenen hipoketotik hipoglisemi, yağ asidi beta oksidasyon kusurunu düşündürür. Orta zincirli açıl-karnitin artışı MCAD eksikliğiyle uyumludur; enerji ve keton üretimi yetersiz kalır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir.", "Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür." ve "Açıl-karnitin profilinde orta zincirli türler artmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase eksikliği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Atak beslenememe ve açlık sonrası gelişmiştir.

Kanıt 2: Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi beklenenden düşüktür.

Kanıt 3: Açıl-karnitin profilinde orta zincirli türler artmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: MCAD eksikliğinde açlık sırasında keton üretilemez; hipoketotik hipoglisemi gelişir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 211: v185-new-211-bebekte-gelisim-geriligi-ve-kuf-kokusu

Başlık: Bebekte gelişim geriliği ve küf kokusu

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Fenilketonüride fenilalanin hidroksilaz defektini klinik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, gelişim geriliği, açık ten rengi ve idrarda farklı koku nedeniyle getiriliyor. Ailesi bebeğin yaşlarına göre geç baş kontrolü kazandığını ve idrarında küf benzeri koku olduğunu belirtmektedir. Yenidoğan taramasının düzenli yapılmadığı öğreniliyor.

Demografi: 7 aylık kız bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Baş çevresi alt persentildedir.
- Cilt ve saç rengi ailesine göre belirgin açıktır.
- Hafif hipertonsite izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma fenilalanin

Etiket: Plazma fenilalanin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Fenilalanin metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Fenilalanin metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma fenilalanin | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Fenilalanin metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Plazma fenilalanin / Belirgin yüksek saptandı. // Fenilalanin metabolizması bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: Tirozin düzeyi

Etiket: Tirozin düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük-normal saptandı. | Klinik anlam: Dönüşüm basamağındaki defekti destekler. | Sonuç yorumu: Dönüşüm basamağındaki defekti destekler. | Sonuç başlığı: Tirozin düzeyi | Sonuç özeti: Düşük-normal saptandı. | Yorum: Dönüşüm basamağındaki defekti destekler. | Satırlar: Tirozin düzeyi / Düşük-normal saptandı. // Dönüşüm basamağındaki defekti destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta en olası enzim defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
B) Homogentizat oksidaz eksikliği
C) Sistationin beta-sentaz eksikliği
D) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği
E) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği

Doğru Cevap: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği

A) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilalanin birikimi, gelişim geriliği ve açık pigmentasyon tablosunu açıklar. Vakadaki “Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.” ve “İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereçlenir.
B) Homogentizat oksidaz eksikliği: Vakadaki Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır ve idrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır. Bu olguda “Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.” ve “İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Fenilalanin hidroksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Sistationin beta-sentaz eksikliği: Sistationin beta-sentaz eksikliği homosistinüri yapar; lens subluksasyonu ve tromboz eğilimi öne çıkar. Bu olguda “Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.” ve “İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Fenilalanin hidroksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği: Galactose-1-phosphate uridytransferase eksikliği sütle beslenme sonrası hepatik sarılık ve kataraktla ilişkilidir. Bu olguda “Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.” ve “İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Fenilalanin hidroksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği akçaağaç şurubu idrar hastalığına neden olur; dallı zincir amino asitler birikir. Bu olguda “Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.” ve “İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Fenilalanin hidroksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bebekte gelişim geriliği ve küf kokusu olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.” ve “İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.” birlikte okunduğunda Fenilalanin hidroksilaz eksikliği seçeneği öne çıkar; “Plazma fenilalanin düzeyi belirgin yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gelişim geriliği, açık pigmentasyon, küf kokusu ve fenilalanin yüksekliği fenilketonüriyi düşündürür. Temel defekt fenilalanini tirozine dönüştüren fenilalanin hidroksilaz enzimidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.”, “İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.” ve “Plazma fenilalanin düzeyi belirgin yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Fenilalanin hidroksilaz eksikliği en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Yenidoğan taraması düzenli yapılmamıştır.

Kanıt 2: İdrarda küf benzeri koku ve açık pigmentasyon vardır.

Kanıt 3: Plazma fenilalanin düzeyi belirgin yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Fenilketonüride fenilalanin kısıtlanır ve tirozin esansiyel hale gelir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 212: v185-new-212-koyu-idrar-ve-eklem-agrisi

Başlık: Koyu idrar ve eklem ağrısı

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Alkaptonürde homogentizat oksidaz eksikliğini klinik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, idrarının bekleyince koyulaşması ve bel-diz ağrıları nedeniyle başvuruyor. Çocukluğundan beri idrarının havayla temas ettikten sonra koyulaştığını fark ettiğini, son yıllarda omurga ve büyük eklemlerde ağrıların arttığını belirtmektedir.

Demografi: 38 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Skleralarda hafif koyu pigmentasyon vardır.
- Omurga hareketleri kısıtlıdır.
- Dizlerde hassasiyet izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar organik asit analizi

Etiket: İdrar organik asit analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Homogentisik asit atılımı artmış saptandı. | Klinik anlam: Tirozin katabolizma bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Tirozin katabolizma bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: İdrar organik asit analizi | Sonuç özeti: Homogentisik asit atılımı artmış saptandı. | Yorum: Tirozin katabolizma bozukluğunu destekler. | Satırlar: İdrar organik asit analizi / Homogentisik asit atılımı artmış saptandı. // Tirozin katabolizma bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel enzim defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Homogentizat oksidaz eksikliği
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
C) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
D) Galaktokinaz eksikliği
E) Glukoz-6-fosfataz eksikliği

Doğru Cevap: Homogentizat oksidaz eksikliği

- A) Homogentizat oksidaz eksikliği: Homogentizat oksidaz eksikliği homogentisik asit birikimiyle koyu idrar ve okronoz tablosunu açıklar. Vakadaki “İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.” ve “Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Vakadaki İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır ve Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır. Bu olguda “İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.” ve “Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Homogentizat oksidaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ornitin transkarbamilaz eksikliği: Vakadaki İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır ve Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır. Bu olguda “İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.” ve “Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Homogentizat oksidaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Galaktokinaz eksikliği: Galaktokinaz eksikliği galaktoz metabolizmasında kataraktla seyreder; koyu idrar-okronoz yapmaz. Bu olguda “İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.” ve “Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Homogentizat oksidaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği açlık hipoglisemisi ve hepatomegali yapar; homogentisik asit birikimiyle ilişkili değildir. Bu olguda “İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.” ve “Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Homogentizat oksidaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Koyu idrar ve eklem ağrısı olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.” ve “Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.” birlikte okunduğunda Homogentizat oksidaz eksikliği seçeneği öne çıkar; “İdrarda homogentisik asit atılımı artmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İdrarın bekleyince koyulaşması, okronotik pigmentasyon ve dejeneratif eklem bulguları alkaptonüriyi düşündürür. Temel defekt tirozin katabolizmasında görevli homogentizat oksidaz eksikliğidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.”, “Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.” ve “İdrarda homogentisik asit atılımı artmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Homogentizat oksidaz eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: İdrar havayla temas sonrası koyulaşmaktadır.

Kanıt 2: Skleralarda koyu pigmentasyon ve eklem yakınmaları vardır.

Kanıt 3: İdrarda homogentisik asit atılımı artmıştır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Alkaptonüri homogentizat oksidaz eksikliğidir; homogentisik asit birikir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 213: v185-new-213-hayvan-isirigi-sonrasi-hidrofobi

Başlık: Hayvan ısırığı sonrası hidrofobi

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Kuduzda temas öyküsü ve Negri cisimcikleriyle etkeni tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yutma güçlüğü, ajitasyon ve su içmeye çalışırken spazm gelişmesi nedeniyle başvuruyor. Bir ay önce sahipsiz köpek tarafından ısırıldığını ancak sağlık kuruluşuna başvurmadığını belirtmektedir. Son günlerde parestezi, ateş, huzursuzluk ve su içme sırasında boğazında kasılma gelişmiştir.

Demografi: 28 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.1°C | Şok indeksi: 1,03 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta ajite ve anksiyetelidir.
- Su içme girişiminde faringeal spazm izlenir.
- Isırık skarı bacakta görülür.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Nöropatolojik değerlendirme

Etiket: Nöropatolojik değerlendirme | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nöronlarda eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlarla uyumlu Negri cisimcikleri tanımlandı. | Klinik anlam: Kuduz enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Kuduz enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Nöropatolojik değerlendirme | Sonuç özeti: Nöronlarda eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlarla uyumlu Negri cisimcikleri tanımlandı. | Yorum: Kuduz enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Nöropatolojik değerlendirme / Nöronlarda eozinofilik sitoplazmik inklüzyonlarla uyumlu Negri cisimcikleri tanımlandı. // Kuduz enfeksiyonunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Rabies virus
- B) Varicella-zoster virus
- C) Cytomegalovirus
- D) Epstein-Barr virus
- E) Hepatitis A virus

Doğru Cevap: Rabies virus

A) Rabies virus: Rabies virus hayvan ısırığı sonrası hidrofobi ve Negri cisimcikleriyle en uyumlu etkindir. Vakadaki "Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır." ve "Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Varicella-zoster virus: Varicella-zoster virus veziküler döküntü ve dermatomal zona yapar; hidrofobi ve Negri cisimciği beklenmez. Bu olguda "Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır." ve "Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Rabies virus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Cytomegalovirus: Vakadaki Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır ve Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir. Bu olguda "Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır." ve "Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Rabies virus seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Epstein-Barr virus: Epstein-Barr virus enfeksiyöz mononükleoz ve bazı lenfomalarla ilişkilidir; hayvan ısırığı sonrası hidrofobi yapmaz. Bu olguda "Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır." ve "Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Rabies virus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hepatitis A virus: Vakadaki Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır ve Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir. Bu olguda "Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır." ve "Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Rabies virus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hayvan ısırığı sonrası hidrofobi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır." ve "Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir." birlikte okunduğunda Rabies virus seçeneği öne çıkar; "Nöronlarda Negri cisimcikleri tanımlanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Aşısız köpek ısırığı sonrası gelişen hidrofobi, ajitasyon, parestezi ve Negri cisimcikleri kuduzu düşündürür. Rabies virus nörotropik bir rhabdovirüstür ve semptomlar başladıktan sonra prognoz çok kötüdür. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır.", "Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir." ve "Nöronlarda Negri cisimcikleri tanımlanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Rabies virus en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Sahipsiz köpek ısırığı sonrası profilaksi yapılmamıştır.

Kanıt 2: Su içme sırasında faringeal spazm gelişmektedir.

Kanıt 3: Nöronlarda Negri cisimcikleri tanımlanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Kuduzda temas sonrası profilaksi semptom başlamadan önce hayat kurtarıcıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 214: v185-new-214-epigastrik-agri-ve-ureaz-pozitifligi

Başlık: Epigastrik ağrı ve üreaz pozitifliği

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Helicobacter pylori enfeksiyonunu üreaz aktivitesi ve peptik ülserle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, açlıkla artan epigastrik ağrı ve gece uykudan uyandıran yanma nedeniyle başvuruyor. Yakınmalarının yemekle kısmen azaldığını, son aylarda sık tekrarladığını belirtmektedir. Nonsteroid antiinflatamatuvar ilaç kullanımı yoktur.

Demografi: 44 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Epigastrik bölgede hafif hassasiyet vardır.
- Akut batın bulgusu yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Üre nefes testi

Etiket: Üre nefes testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Üreaz aktivitesi olan mide kolonizasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Üreaz aktivitesi olan mide kolonizasyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Üre nefes testi | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Üreaz aktivitesi olan mide kolonizasyonunu destekler. | Satırlar: Üre nefes testi / Pozitif saptandı. // Üreaz aktivitesi olan mide kolonizasyonunu destekler.

Tetkik 2: Üst gastrointestinal endoskopi

Etiket: Üst gastrointestinal endoskopi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Duodenum bulbusta ülser izlendi. | Klinik anlam: Peptik ülser hastalığını destekler. | Sonuç yorumu: Peptik ülser hastalığını destekler. | Sonuç başlığı: Üst gastrointestinal endoskopi | Sonuç özeti: Duodenum bulbusta ülser izlendi. | Yorum: Peptik ülser hastalığını destekler. | Satırlar: Üst gastrointestinal endoskopi / Duodenum bulbusta ülser izlendi. // Peptik ülser hastalığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-110 | Başlık: Üst gastrointestinal endoskopi | Modalite: endoscopy | Bulgu: Duodenum bulbusta ülser izlendi. | Klinik anlam: Peptik ülser hastalığını destekler. | URL: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/110_110-duodenal-ulser-endoskopi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/110_110-duodenal-ulser-endoskopi.webp | Alt text: Üst gastrointestinal endoskopi - Duodenum bulbusta ülser izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Helicobacter pylori
B) Campylobacter jejuni
C) Vibrio cholerae
D) Salmonella enterica
E) Clostridioides difficile

Doğru Cevap: Helicobacter pylori

- A) Helicobacter pylori: Helicobacter pylori üreaz pozitifliği ve duodenal ülserle en uyumlu mikroorganizmadır. Vakadaki "Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır." ve "Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Campylobacter jejuni: Campylobacter jejuni inflamatuvar ishal ve karın ağrısıyla ilişkilidir; üre nefes testi pozitifliği yapmaz. Bu olguda "Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır." ve "Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Helicobacter pylori seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Vibrio cholerae: Vakadaki Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır ve Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir. Bu olguda "Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır." ve "Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Helicobacter pylori seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Salmonella enterica: Salmonella enterica gastroenterit veya enterik ateş yapabilir; kronik duodenal ülserin tipik nedeni değildir. Bu olguda "Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır." ve "Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Helicobacter pylori seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Clostridioides difficile: Clostridioides difficile antibiyotik sonrası psödomembranöz kolit yapar; duodenal ülser paternini açıklamaz. Bu olguda "Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır." ve "Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Helicobacter pylori seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Epigastrik ağrı ve üreaz pozitifliği olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır." ve "Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir." birlikte okunduğunda Helicobacter pylori seçeneği öne çıkar; "Üre nefes testi pozitif saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Duodenal ülser ve pozitif üre nefes testi Helicobacter pylori enfeksiyonunu düşündürür. Bu bakteri üreaz üretimiyle mide asidik ortamında amonyak oluşturarak yaşamını sürdürür ve peptik ülser patogeneze katkı sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır.", "Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir." ve "Üre nefes testi pozitif saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Helicobacter pylori en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Epigastrik ağrı açlıkla artmakta ve yemekle kısmen azalmaktadır.

Kanıt 2: Endoskopide duodenum ülseri izlenmiştir.

Kanıt 3: Üre nefes testi pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayrılar.

Exam Pearl: Helicobacter pylori üreaz pozitifdir ve duodenal ülserle güçlü ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 215: v185-new-215-transplant-sonrasi-gorme-bulanikligi

Başlık: Transplant sonrası görme bulanıklığı

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Sitomegalovirüs enfeksiyonunda baykuş gözü inklüzyonlarını immünsüpresyonla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, böbrek nakli sonrası görme bulanıklığı ve ateş nedeniyle başvuruyor. Üç ay önce böbrek nakli olduğu ve immünsüpresif tedavi kullandığı öğreniliyor. Son haftalarda halsizlik, düşük dereceli ateş ve sağ gözde bulanık görme gelişmiştir.

Demografi: 52 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.0°C | Şok indeksi: 1,39 (yüksek)

Fizik Muayene

- Fundoskopik değerlendirmede retinal hemoraji ve nekrotizan retinit alanları bildirilmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma viral PCR

Etiket: Plazma viral PCR | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Cytomegalovirus DNA pozitif ve yüksek düzeyde saptandı. | Klinik anlam: Aktif CMV enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Aktif CMV enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma viral PCR | Sonuç özeti: Cytomegalovirus DNA pozitif ve yüksek düzeyde saptandı. | Yorum: Aktif CMV enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Plazma viral PCR / Cytomegalovirus DNA pozitif ve yüksek düzeyde saptandı. // Aktif CMV enfeksiyonunu destekler.

Tetkik 2: Doku sitolojisi

Etiket: Doku sitolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: İntranükleer inklüzyonlu, baykuş gözü görünümünde hücreler izlendi. | Klinik anlam: CMV için karakteristik sitopatik bulgudur. | Sonuç yorumu: CMV için karakteristik sitopatik bulgudur. | Sonuç başlığı: Doku sitolojisi | Sonuç özeti: İntranükleer inklüzyonlu, baykuş gözü görünümünde hücreler izlendi. | Yorum: CMV için karakteristik sitopatik bulgudur. | Satırlar: Doku sitolojisi / İntranükleer inklüzyonlu, baykuş gözü görünümünde hücreler izlendi. // CMV için karakteristik sitopatik bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-111 | Başlık: Doku sitolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: İntranükleer inklüzyonlu, baykuş gözü görünümünde hücreler izlendi. | Klinik anlam: CMV için karakteristik sitopatik bulgudur. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/111_111-cmv-baykus-gozu-inkluzonlari-sitoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/111_111-cmv-baykus-gozu-inkluzonlari-sitoloji.webp | Alt text: Doku sitolojisi - İntranükleer inklüzyonlu, baykuş gözü görünümünde hücreler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cytomegalovirus
B) Herpes simplex virus tip 1
C) Varicella-zoster virus
D) Adenovirus
E) Parvovirus B19

Doğru Cevap: Cytomegalovirus

- A) Cytomegalovirus: Cytomegalovirus transplant hastasında retinit ve baykuş gözü inklüzyonlarıyla en uyumlu etkindir. Vakadaki “Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.” ve “Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Herpes simplex virus tip 1: Herpes simplex virus tip 1 oral lezyon ve ensefalit yapabilir; baykuş gözü inklüzyonları CMV için daha tipiktir. Bu olguda “Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.” ve “Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Cytomegalovirus seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Varicella-zoster virus: Varicella-zoster virus dermatomal veziküler döküntüyle ilişkilidir; bu olguda CMV PCR ve inklüzyon bulgusu vardır. Bu olguda “Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.” ve “Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Cytomegalovirus seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Adenovirus: Adenovirus solunum, konjonktivit veya gastroenterit yapabilir; transplant retinit ve baykuş gözü paternini açıklamaz. Bu olguda “Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.” ve “Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Cytomegalovirus seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Parvovirus B19: Parvovirus B19 eritroid seri aplazisi ve beşinci hastalıkla ilişkilidir; retinit ve CMV inklüzyonu yapmaz. Bu olguda “Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.” ve “Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Cytomegalovirus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Transplant sonrası görme bulanıklığı olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.” ve “Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.” birlikte okunduğunda Cytomegalovirus seçeneği öne çıkar; “PCR pozitifliği ve baykuş gözü inklüzyonları gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Transplant alıcısında immünsüpresyon altında ateş ve retinit gelişmesi, PCR pozitifliği ve baykuş gözü intranükleer inklüzyonlar CMV enfeksiyonunu düşündürür. CMV özellikle hücrel immünitesi baskılanmış hastalarda ağır hastalık yapabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.”, “Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.” ve “PCR pozitifliği ve baykuş gözü inklüzyonları gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Cytomegalovirus en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Hasta böbrek nakli sonrası immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.

Kanıt 2: Fundoskopide nekrotizan retinit bulguları vardır.

Kanıt 3: PCR pozitifliği ve baykuş gözü inklüzyonları gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: CMV’de baykuş gözü intranükleer inklüzyonlar klasik sitopatik bulgudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 216: v185-new-216-kronik-oksuruk-ve-granulom

Başlık: Kronik öksürük ve granülom

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Tüberkülozda kazeifiye granülom paternini klinik ve histolojiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, uzun süren öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki aydır öksürük ve halsizlik tarifliyor. Son bir ayda kilo kaybı ve gece terlemesi belirginleşmiştir. Daha önce tüberkülozlu bir ev arkadaşıyla temas öyküsü vardır.

Demografi: 37 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.9°C | Şok indeksi: 0,81

Fizik Muayene

- Zayıf görünüm vardır.
- Akciğer üst zonlarında ral duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer görüntülemesi

Etiket: Akciğer görüntülemesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Üst loblarda kaviter lezyonlar izlendi. | Klinik anlam: Reaktivasyon tüberkülozu lehine bulgudur. | Sonuç yorumu: Reaktivasyon tüberkülozu lehine bulgudur. | Sonuç başlığı: Akciğer görüntülemesi | Sonuç özeti: Üst loblarda kaviter lezyonlar izlendi. | Yorum: Reaktivasyon tüberkülozu lehine bulgudur. | Satırlar: Akciğer görüntülemesi / Üst loblarda kaviter lezyonlar izlendi. // Reaktivasyon tüberkülozu lehine bulgudur.

Tetkik 2: Biyopsi histopatolojisi

Etiket: Biyopsi histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Merkezinde kazeöz nekroz bulunan epitelioid histiyosit ve dev hücrelerden oluşan granülomlar izlendi. | Klinik anlam: Tüberkülozla uyumlu granülomatöz inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Tüberkülozla uyumlu granülomatöz inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Biyopsi histopatolojisi | Sonuç özeti: Merkezinde kazeöz nekroz bulunan epitelioid histiyosit ve dev hücrelerden oluşan granülomlar izlendi. | Yorum: Tüberkülozla uyumlu granülomatöz inflamasyonu destekler. | Satırlar: Biyopsi histopatolojisi / Merkezinde kazeöz nekroz bulunan epitelioid histiyosit ve dev hücrelerden oluşan granülomlar izlendi. // Tüberkülozla uyumlu granülomatöz inflamasyonu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-112 | Başlık: Biyopsi histopatolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Merkezinde kazeöz nekroz bulunan epitelioid histiyosit ve dev hücrelerden oluşan granülomlar izlendi. | Klinik anlam: Tüberkülozla uyumlu granülomatöz inflamasyonu destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/112_112-kazeifiye-granulom-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/112_112-kazeifiye-granulom-histopatoloji.webp | Alt text: Biyopsi histopatolojisi - Merkezinde kazeöz nekroz bulunan epitelioid histiyosit ve dev hücrelerden oluşan granülomlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada beklenen karakteristik patolojik patern aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kazeifiye granülomatöz inflamasyon
B) Fibrinoid nekrozlu küçük damar vaskülit
C) Saf pürülan abse formasyonu
D) Amiloid birikimi
E) Displastik skuamöz epitel proliferasyonu

Doğru Cevap: Kazeifiye granülomatöz inflamasyon

- A) Kazeifiye granülomatöz inflamasyon: Kazeifiye granülomatöz inflamasyon tüberkülozun klinik ve histolojik bulgularını en iyi açıklar. Vakadaki “Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.” ve “Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Fibrinoid nekrozlu küçük damar vaskülit: Fibrinoid nekrozlu küçük damar vaskülit immün vaskülitlerde beklenir; kaviteli akciğer tüberkülozunun klasik paterni değildir. Bu olguda “Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.” ve “Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Kazeifiye granülomatöz inflamasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Saf pürülan abse formasyonu: Saf pürülan abse formasyonu tipik piyoenik bakteriyel enfeksiyonları düşündürür; burada granülomatöz patern vardır. Bu olguda “Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.” ve “Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Kazeifiye granülomatöz inflamasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Amiloid birikimi: Amiloid birikimi kronik inflamasyonun komplikasyonu olabilir ancak bu biyopsinin primer tanısıl paterni değildir. Bu olguda “Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.” ve “Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Kazeifiye granülomatöz inflamasyon seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Displastik skuamöz epitel proliferasyonu: Displastik skuamöz epitel proliferasyonu prekanseröz epitel lezyonlarını ifade eder; kazeöz granülomla uyumlu değildir. Bu olguda “Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.” ve “Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Kazeifiye granülomatöz inflamasyon seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik öksürük ve granülom olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.” ve “Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Kazeifiye granülomatöz inflamasyon seçeneği öne çıkar; “Histolojide kazeöz nekrozlu granülomlar gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı, üst lob kaviter lezyon ve merkezinde kazeöz nekroz bulunan granülomlar tüberkülozla uyumludur. Kazeifiye granülomatöz inflamasyon bu enfeksiyonun klasik patolojik paternidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.”, “Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.” ve “Histolojide kazeöz nekrozlu granülomlar gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kazeifiye granülomatöz inflamasyon en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kronik öksürük, gece terlemesi ve kilo kaybı vardır.

Kanıt 2: Üst loblarda kaviter lezyon izlenmiştir.

Kanıt 3: Histolojide kazeöz nekrozlu granülomlar gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Tüberkülozda klasik histolojik bulgu kazeifiye granülomdur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 217: v185-new-217-uzun-sureli-reflu-sonrasi-biyopsi-bulgusu

Başlık: Uzun süreli reflü sonrası biyopsi bulgusu

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Barrett özofagusunda intestinal metaplazi ve adenokarsinom riskini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yıllardır süren reflü yakınmaları nedeniyle yapılan endoskopi sonrası değerlendirilir. Yaklaşık 10 yıldır yanma ve ağza acı su gelmesi yakınmaları olduğunu, özellikle gece yattığında arttığını belirtir. Son aylarda ilaç kullanmasına rağmen yakınmaları devam etmiştir.

Demografi: 55 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fizik muayenede akut patoloji saptanmaz.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Üst gastrointestinal endoskopi

Etiket: Üst gastrointestinal endoskopi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Distal özofagusta somon renkli mukozal alanlar izlendi. | Klinik anlam: Metaplastik değişiklik açısından şüphelidir. | Sonuç yorumu: Metaplastik değişiklik açısından şüphelidir. | Sonuç başlığı: Üst gastrointestinal endoskopi | Sonuç özeti: Distal özofagusta somon renkli mukozal alanlar izlendi. | Yorum: Metaplastik değişiklik açısından şüphelidir. | Satırlar: Üst gastrointestinal endoskopi / Distal özofagusta somon renkli mukozal alanlar izlendi. // Metaplastik değişiklik açısından şüphelidir.

Tetkik 2: Özofagus biyopsisi

Etiket: Özofagus biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Goblet hücreleri içeren intestinal tip kolumnar metaplazi izlendi. | Klinik anlam: Barrett özofagusu için tanısal bulgudur. | Sonuç yorumu: Barrett özofagusu için tanısal bulgudur. | Sonuç başlığı: Özofagus biyopsisi | Sonuç özeti: Goblet hücreleri içeren intestinal tip kolumnar metaplazi izlendi. | Yorum: Barrett özofagusu için tanısal bulgudur. | Satırlar: Özofagus biyopsisi / Goblet hücreleri içeren intestinal tip kolumnar metaplazi izlendi. // Barrett özofagusu için tanısal bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-113 | Başlık: Üst gastrointestinal endoskopi | Modalite: endoscopy | Bulgu: Distal özofagusta somon renkli mukozal alanlar izlendi. | Klinik anlam: Metaplastik değişiklik açısından şüphelidir. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/113_113-barrett-ozofagus-endoskopi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/113_113-barrett-ozofagus-endoskopi.webp | Alt text: Üst gastrointestinal endoskopi - Distal özofagusta somon renkli mukozal alanlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-114 | Başlık: Özofagus biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Goblet hücreleri içeren intestinal tip kolumnar metaplazi izlendi. | Klinik anlam: Barrett özofagusu için tanısal bulgudur. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/114_114-barrett-ozofagus-intestinal-metaplazi-histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/114_114-barrett-ozofagus-intestinal-metaplazi-histopatoloji.webp | Alt text: Özofagus biyopsisi - Goblet hücreleri içeren intestinal tip kolumnar metaplazi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada uzun dönemde artan malignite riski en çok aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Özofagus adenokarsinomu
- B) Özofagus skuamöz hücreli karsinomu
- C) Gastrik lenfoma
- D) Kolon nöroendokrin tümörü
- E) Hepatoselüler karsinom

Doğru Cevap: Özofagus adenokarsinomu

A) Özofagus adenokarsinomu: Özofagus adenokarsinomu Barrett özofagusundaki goblet hücreli intestinal metaplazinin artırdığı temel malignite riskidir. Vakadaki “Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.” ve “Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Özofagus skuamöz hücreli karsinomu: Özofagus skuamöz hücreli karsinomu daha çok sigara, alkol ve kostik hasar gibi risklerle ilişkilidir; Barrett için klasik değildir. Bu olguda “Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.” ve “Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.” ipuçları klinik karar açısından Özofagus adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Gastrik lenfoma: Gastrik lenfoma *Helicobacter pylori* ilişkili MALT lenfoma bağlamında düşünülür; distal özofagus metaplazisinin ana riski değildir. Bu olguda “Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.” ve “Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.” ipuçları klinik karar açısından Özofagus adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Kolon nöroendokrin tümörü: Vakadaki Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır ve Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür. Bu olguda “Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.” ve “Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.” ipuçları klinik karar açısından Özofagus adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hepatoselüler karsinom: Hepatoselüler karsinom kronik hepatit ve sirozla ilişkilidir; reflüye bağlı özofagus metaplazisiyle açıklanmaz. Bu olguda “Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.” ve “Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.” ipuçları klinik karar açısından Özofagus adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzun süreli reflü sonrası biyopsi bulgusu olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.” ve “Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.” birlikte okunduğunda Özofagus adenokarsinomu seçeneği öne çıkar; “Biyopside goblet hücreli intestinal metaplazi saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uzun süreli gastroözofageal reflü distal özofagusta intestinal metaplaziye yol açabilir. Goblet hücreli intestinal metaplazi Barrett özofagusudur ve özofagus adenokarsinomu riskini artırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.”, “Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.” ve “Biyopside goblet hücreli intestinal metaplazi saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Özofagus adenokarsinomu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada uzun süreli reflü yakınmaları vardır.

Kanıt 2: Endoskopide distal özofagusta somon renkli mukoza görülmüştür.

Kanıt 3: Biyopside goblet hücreli intestinal metaplazi saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Barrett özofagusu distal özofagus adenokarsinomu riskini artırır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 218: v185-new-218-tiroid-nodulunde-sitoloji-bulgusu

Başlık: Tiroid nodülünde sitoloji bulgusu

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Papiller tiroid kansinomunda karakteristik nükleer özellikleri tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, boyunda ele gelen tiroid nodülü nedeniyle başvuruyor. Son aylarda boynun ön kısmında yavaş büyüyen, ağrısız bir şişlik fark ettiğini belirtmektedir. Çocukluk döneminde baş-boyun radyasyon öyküsü vardır.

Demografi: 42 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Tiroid sağ lobda sert, düzensiz sınırlı nodül palpe edilir.
- Servikal bölgede küçük lenf nodları hissedilir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tiroid ultrasonografisi

Etiket: Tiroid ultrasonografisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Mikrokalsifikasyon içeren hipoekoik nodül izlendi. | Klinik anlam: Malignite şüphesini artırır. | Sonuç yorumu: Malignite şüphesini artırır. | Sonuç başlığı: Tiroid ultrasonografisi | Sonuç özeti: Mikrokalsifikasyon içeren hipoekoik nodül izlendi. | Yorum: Malignite şüphesini artırır. | Satırlar: Tiroid ultrasonografisi / 1.8 cm // Malignite şüphesini artırır.

Tetkik 2: İnce iğne aspirasyon sitolojisi

Etiket: İnce iğne aspirasyon sitolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Nükleer yarıklar, psödoinklüzyonlar ve berrak nükleer görünüm izlendi. | Klinik anlam: Papiller tiroid kansinomu lehinedir. | Sonuç yorumu: Papiller tiroid kansinomu lehinedir. | Sonuç başlığı: İnce iğne aspirasyon sitolojisi | Sonuç özeti: Nükleer yarıklar, psödoinklüzyonlar ve berrak nükleer görünüm izlendi. | Yorum: Papiller tiroid kansinomu lehinedir. | Satırlar: İnce iğne aspirasyon sitolojisi / Nükleer yarıklar, psödoinklüzyonlar ve berrak nükleer görünüm izlendi. // Papiller tiroid kansinomu lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-115 | Başlık: Tiroid ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Mikrokalsifikasyon içeren hipoekoik nodül izlendi. | Klinik anlam: Malignite şüphesini artırır. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/115_115-tiroid-hipoekoik-nodul-mikrokalsifikasyon-ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/115_115-tiroid-hipoekoik-nodul-mikrokalsifikasyon-ultrasonografi.webp | Alt text: Tiroid ultrasonografisi - Mikrokalsifikasyon içeren hipoekoik nodül izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-116 | Başlık: İnce iğne aspirasyon sitolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Nükleer yarıklar, psödoinklüzyonlar ve berrak nükleer görünüm izlendi. | Klinik anlam: Papiller tiroid kansinomu lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/116_papiller_tiroid_karsinomu_sitoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/116_papiller_tiroid_karsinomu_sitoloji.webp | Alt text: İnce iğne aspirasyon sitolojisi - Nükleer yarıklar, psödoinklüzyonlar ve berrak nükleer görünüm izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Papiller tiroid kansinomu
B) Folliküler tiroid adenom
C) Medüller tiroid kansinomu
D) Anaplastik tiroid kansinomu
E) Hashimoto tiroiditi

Doğru Cevap: Papiller tiroid kansinomu

- A) Papiller tiroid kansinomu: Papiller tiroid kansinomu mikrokalsifikasyon, lenf nodu eğilimi ve karakteristik nükleer özelliklerle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.” ve “Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Folliküler tiroid adenom: Folliküler adenom kapsüllü benign lezyondur; papiller kansinomun nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon bulgularını açıklamaz. Bu olguda “Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.” ve “Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Papiller tiroid kansinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Medüller tiroid kansinomu: Medüller tiroid kansinomu parafolliküler C hücrelerinden gelişir ve kalsitonin-amiloid stromayla ilişkilidir. Bu olguda “Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.” ve “Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Papiller tiroid kansinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Anaplastik tiroid kansinomu: Anaplastik kansinom yaşlılarda hızla büyüyen agresif kitle yapar; bu sitolojik nükleer patern papiller kansinom lehinedir. Bu olguda “Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.” ve “Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Papiller tiroid kansinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Hashimoto tiroiditi: Hashimoto tiroiditi otoimmün hipotiroidi ve lenfositik infiltrasyonla seyrederek mikrokalsifikasyonlu nodül ve papiller nükleer özellikler beklenmez. Bu olguda “Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.” ve “Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Papiller tiroid kansinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tiroid nodülünde sitoloji bulgusu olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.” ve “Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Papiller tiroid kansinomu seçeneği öne çıkar; “Servikal lenf nodları palpe edilmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Baş-boyun radyasyon öyküsü, mikrokalsifikasyonlu tiroid nodülü, servikal lenf nodları ve nükleer yarıklar-psödoinklüzyon-berrak nükleer görünüm papiller tiroid kansinomunu düşündürür. Bu tümör lenfatik yayılım eğilimi gösterir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.”, “Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.” ve “Servikal lenf nodları palpe edilmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Papiller tiroid kansinomu en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Tiroid nodülünde mikrokalsifikasyon vardır.

Kanıt 2: Sitolojide nükleer yarıklar ve psödoinklüzyon izlenmiştir.

Kanıt 3: Servikal lenf nodları palpe edilmektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Papiller tiroid kansinomunda orphan Annie eye nükleus, nükleer yarıklar ve psammoma cisimcikleri klasik bulgulardır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 219: v185-new-219-tansiyon-ilaci-sonrasi-hisilti

Başlık: Tansiyon ilacı sonrası hisilti

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Nonselektif beta blokerin astımda bronkospazm riskini reseptör düzeyinde açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yeni başlanan tansiyon ilacından sonra gelişen nefes darlığı ve hisilti nedeniyle başvuruyor. Astım öyküsü olan hastaya migren profilaksisi ve hipertansiyon için propranolol başlandığı öğreniliyor. İlacı aldıktan sonra hisilti ve göğüste sıkışma gelişmiştir.

Demografi: 45 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 158/94 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 26/dk | SpO₂: %93% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,56

Fizik Muayene

- Ekspiryumda yaygın hisilti duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablonun en olası farmakolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı
B) Muskarinik reseptör blokajı
C) Alfa-1 reseptör aktivasyonu
D) Histamin H2 reseptör blokajı
E) Dopamin D2 reseptör blokajı

Doğru Cevap: Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı

A) Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı: Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı propranololün astımlı hastada bronkospazm oluşturmalarının temel mekanizmasıdır.

Vakadaki "Hastada astım öyküsü vardır." ve "Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Muskarinik reseptör blokajı: Vakadaki Hastada astım öyküsü vardır ve Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir. Bu olguda "Hastada astım öyküsü vardır." ve "Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Alfa-1 reseptör aktivasyonu: Alfa-1 reseptör aktivasyonu vazokonstriksiyonla ilişkilidir; propranololün bronkospazm mekanizması değildir. Bu olguda "Hastada astım öyküsü vardır." ve "Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Histamin H2 reseptör blokajı: Vakadaki Hastada astım öyküsü vardır ve Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir. Bu olguda "Hastada astım öyküsü vardır." ve "Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Dopamin D2 reseptör blokajı: Dopamin D2 reseptör blokajı ekstrapiramidal yan etkilerle ilişkilidir; astım atağı mekanizması değildir. Bu olguda "Hastada astım öyküsü vardır." ve "Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kan basıncı ilacı sonrası hisilti olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Hastada astım öyküsü vardır." ve "Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir." birlikte okunduğunda Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı seçeneği öne çıkar; "Muayenede yaygın ekspiryum hisiltisi duyulmuştur." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Propranolol nonselektif beta blokerdir ve beta-1 ile beta-2 reseptörleri bloke eder. Astımlı hastada bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı bronkodilatasyonu engelleyerek bronkospazm ve hisiltiyi yol açabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada astım öyküsü vardır.", "Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir." ve "Muayenede yaygın ekspiryum hisiltisi duyulmuştur." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Bronş düz kasındaki beta-2 reseptör blokajı en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada astım öyküsü vardır.

Kanıt 2: Yakınmalar propranolol başlandıktan sonra gelişmiştir.

Kanıt 3: Muayenede yaygın ekspiryum hisiltisi duyulmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Astımda nonselektif beta blokerler beta-2 blokajı nedeniyle bronkospazm yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 220: v185-new-220-tedavi-sonrasi-isitme-azalması

Başlık: Tedavi sonrası işitme azalması

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Aminoglikozidlerin etki mekanizması ve toksisite profilini klinik kullanımla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, gram-negatif sepsis tedavisi sırasında gelişen kulak çınlaması ve işitme azalması nedeniyle değerlendiriliyor. Pseudomonas riski nedeniyle gentamisin içeren tedavi aldığı öğreniliyor. Tedavinin beşinci gününde kulak çınlaması ve dengesizlik başlamıştır. Kronik böbrek hastalığı öyküsü vardır.

Demografi: 66 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bilinci açık ve koopere durumdadır.
- İditme deęerlendirmesinde bilateral azalma řüphesi vardır.
- Hafif ataksi izlenir.
- Hemodinamik instabilite dūřündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aminoglikozid toksisitesi riskini artırır. | Sonuç yorumu: Aminoglikozid toksisitesi riskini artırır. | Sonuç bařlıęı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Aminoglikozid toksisitesi riskini artırır. | Satırlar: Serum kreatinin / 2.1 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Aminoglikozid toksisitesi riskini artırır.

Görseller

Bu vaka için baęlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu ilacın temel antibakteriyel etki mekanizması ařaęıdakilerden hangisidir?

- A) 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak
B) 50S ribozomal alt birimde peptidil transferazı inhibe etmek
C) Hücre duvarında transpeptidaz enzimlerini inhibe etmek
D) DNA girazı inhibe etmek
E) Folat sentezinde dihidropteroat sentazı inhibe etmek

Doęru Cevap: 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak

A) 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak: 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak aminoglikozidlerin temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.” ve “Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.” ipuçları birlikte deęerlendirildięinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) 50S ribozomal alt birimde peptidil transferazı inhibe etmek: 50S peptidil transferaz inhibisyonu kloramfenikol gibi ilaçlarla iliřkilidir; gentamisinin mekanizması deęildir. Bu olguda “Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.” ve “Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.” ipuçları mekanizma bilgisi aęısından 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak seçeneęini daha güçlü kılar.
C) Hücre duvarında transpeptidaz enzimlerini inhibe etmek: Vakadaki Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır ve Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir. Bu olguda “Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.” ve “Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.” ipuçları mekanizma bilgisi aęısından 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak seçeneęini daha güçlü kılar.
D) DNA girazı inhibe etmek: Vakadaki Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır ve Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir. Bu olguda “Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.” ve “Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.” ipuçları mekanizma bilgisi aęısından 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak seçeneęini daha güçlü kılar.
E) Folat sentezinde dihidropteroat sentazı inhibe etmek: Vakadaki Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır ve Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir. Bu olguda “Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.” ve “Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.” ipuçları mekanizma bilgisi aęısından 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak seçeneęini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tedavi sonrası iřitme azalması olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.” ve “Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.” birlikte okunduęunda 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak seçeneęi öne çıkar; “Kreatinin yükseklięi toksisite riskini artırmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirlięini artırır.

Rationale: Gentamisin bir aminoglikoziddir; 30S ribozomal alt birime baęlanarak mRNA yanlıř okunmasına ve bakterisidal etkiye yol açar. Nefrotoksisite ve ototoksisite özellikle renal fonksiyon bozukluęunda önemli yan etkilerdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.”, “Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.” ve “Kreatinin yükseklięi toksisite riskini artırmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle 30S ribozomal alt birime baęlanarak protein sentezinde yanlıř okumaya neden olmak en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hasta gentamisin içeren tedavi almaktadır.

Kanıt 2: Kulak çınlaması, iřitme azalması ve dengesizlik geliřmiřtir.

Kanıt 3: Kreatinin yükseklięi toksisite riskini artırmaktadır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamaęa baęlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduęunda ayrılır.

Exam Pearl: Aminoglikozidler 30S alt birime baęlanır, bakterisidaldır ve oto-nefrotoksisite yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doęru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 221: v185-new-221-stent-sonrası-ikili-antiagregan-tedavi

Başlık: Stent sonrası ikili antiagregan tedavi

Branř: medical-pharmacology | İlgili Branř: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla iliřkilendirme.

Learning Target: Klopidoğrelin P2Y12 reseptör inhibisyonu ile antiplatelet etki mekanizmasını aęıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, koroner stent sonrası verilen antiagregan tedavinin mekanizmasını öęrenmek istemektedir. Akut koroner sendrom sonrası perkütan koroner giriřim yapıldıęı ve asetilsalisilik asit ile klopidoğrel bařlandıęı öęreniliyor. Aktif kanaması yoktur.

Demografi: 58 yařında erkek hasta | Setting: Klinik deęerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 126/78 mmHg | Nabız: 74/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateř: 36.7°C | řok indeksi: 0,59

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Fizik muayenede akut patoloji saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için baęlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Klopidoğrel'in temel antiplatelet etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek
- B) Trombinin fibrinojeni fibrine çevirmesini doğrudan inhibe etmek
- C) Vitamin K epoksit redüktazı inhibe etmek
- D) Antitrombin III aktivitesini artırmak
- E) Siklooksijenazı geri dönüşümlü inhibe etmek

Doğru Cevap: Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek

A) Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek: Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek klopidoğrel'in temel antiplatelet etki mekanizmasıdır. Vakadaki "Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır." ve "Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Trombinin fibrinojeni fibrine çevirmesini doğrudan inhibe etmek: Trombinin fibrinojeni fibrine çevirmesini doğrudan inhibe etmek dabigatran gibi doğrudan trombin inhibitörleriyle ilişkilidir. Bu olguda "Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır." ve "Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Vitamin K epoksit redüktazı inhibe etmek: Vitamin K epoksit redüktaz inhibisyonu warfarinin mekanizmasıdır; klopidoğrel trombosit reseptörünü hedefler. Bu olguda "Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır." ve "Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Antitrombin III aktivitesini artırmak: Antitrombin III aktivitesini artırmak heparinin mekanizmasıdır; klopidoğrel için uygun değildir. Bu olguda "Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır." ve "Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Siklooksijenazı geri dönüşümlü inhibe etmek: Siklooksijenazı geri dönüşümsüz inhibe etmek asetilsalisilik asidin antiplatelet mekanizmasıdır; klopidoğrel P2Y12 reseptörünü hedefler. Bu olguda "Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır." ve "Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Stent sonrası ikili antiagregan tedavi olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır." ve "Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır." birlikte okunduğunda Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek seçeneği öne çıkar; "Aktif kanama veya alternatif antikoagülan kullanım bağlamı verilmemiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Klopidoğrel trombositlerde P2Y12 ADP reseptörünü irreversibl inhibe eder. Böylece ADP aracılı trombosit aktivasyonu ve glikoprotein IIb/IIIa üzerinden agregasyon azalır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır.", "Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır." ve "Aktif kanama veya alternatif antikoagülan kullanım bağlamı verilmemiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Trombosit P2Y12 ADP reseptörünü inhibe etmek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastaya koroner stent sonrası klopidoğrel başlanmıştır.

Kanıt 2: Tedavi antiagregan amaçla kullanılmaktadır.

Kanıt 3: Aktif kanama veya alternatif antikoagülan kullanım bağlamı verilmemiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Klopidoğrel P2Y12 ADP reseptörünü inhibe eden antiplatelet ilaçtır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 222: v185-new-222-ani-sirt-agrisi-ve-hipotansiyon

Başlık: Ani sırt ağrısı ve hipotansiyon

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Rüptüre abdominal aort anevrizmasında hemodinamik instabiliteyle acil cerrahi yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan şiddetli karın-sırt ağrısı ve bayılma nedeniyle acile getiriliyor. Uzun süreli sigara ve hipertansiyon öyküsü vardır. Ağrının aniden başladığı, sırta yayıldığı ve ardından baygınlık hissi geliştiği öğreniliyor.

Demografi: 74 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 72/46 mmHg | Nabız: 138/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1.92 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve terli görünümündedir.
- Batında pulsatil kitle palpe edilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yatak başı abdominal ultrasonografi

Etiket: Yatak başı abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Abdominal aortta geniş anevrizmatik dilatasyon ve retroperitoneal sıvı şüphesi izlendi. | Klinik anlam: Rüptür riski ve acil yaklaşım açısından anlamlıdır. | Sonuç yorumu: Rüptür riski ve acil yaklaşım açısından anlamlıdır. | Sonuç başlığı: Yatak başı abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Abdominal aortta geniş anevrizmatik dilatasyon ve retroperitoneal sıvı şüphesi izlendi. | Yorum: Rüptür riski ve acil yaklaşım açısından anlamlıdır. | Satırlar: Yatak başı abdominal ultrasonografi / 7.2 cm // Rüptür riski ve acil yaklaşım açısından anlamlıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-117 | Başlık: Yatak başı abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Abdominal aortta geniş anevrizmatik dilatasyon ve retroperitoneal sıvı şüphesi izlendi. | Klinik anlam: Rüptür riski ve acil yaklaşım açısından anlamlıdır. | URL: https://iukbtlkzictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/117_abdominal_aort_anevrizmasi_yatak_basi_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/117_abdominal_aort_anevrizmasi_yatak_basi_usg.webp | Alt text: Yatak başı abdominal ultrasonografi - Abdominal aortta geniş anevrizmatik dilatasyon ve retroperitoneal sıvı şüphesi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı
- B) Elektif poliklinik kontrolü planlanması

- C) Oral antihipertansif verilmesi
D) Analjezik tedavi sonrası ayakta izlem
E) Kolonoskopi hazırlığı başlanması

Doğru Cevap: Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı

A) Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı: Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı rüptüre anevrizmada hayat kurtarıcı yaklaşımdır. Vakadaki “Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.” ve “Hasta hipotansif ve taşikardiktir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Elektif poliklinik kontrolü planlanması: Vakadaki Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır ve Hasta hipotansif ve taşikardiktir. Bu olguda “Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.” ve “Hasta hipotansif ve taşikardiktir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Oral antihipertansif verilmesi: Vakadaki Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır ve Hasta hipotansif ve taşikardiktir. Bu olguda “Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.” ve “Hasta hipotansif ve taşikardiktir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Analjezik tedavi sonrası ayakta izlem: Vakadaki Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır ve Hasta hipotansif ve taşikardiktir. Bu olguda “Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.” ve “Hasta hipotansif ve taşikardiktir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Kolonoskopi hazırlığı başlanması: Vakadaki Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır ve Hasta hipotansif ve taşikardiktir. Bu olguda “Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.” ve “Hasta hipotansif ve taşikardiktir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani sırt ağrısı ve hipotansiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.” ve “Hasta hipotansif ve taşikardiktir.” birlikte okunduğunda Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı seçeneği öne çıkar; “Batında pulsatil kitle ve geniş aort anevrizması saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipotansiyon, ani karın-sırt ağrısı, pulsatil abdominal kitle ve geniş anevrizma rüptüre abdominal aort anevrizmasını düşündürür. Bu tablo ölümcül kanama riski taşıdığından resüsitasyonla eş zamanlı acil cerrahi veya endovasküler onarım gerektirir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.”, “Hasta hipotansif ve taşikardiktir.” ve “Batında pulsatil kitle ve geniş aort anevrizması saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hemodinamik resüsitasyonla eş zamanlı acil damar cerrahisi onarımı en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Ani başlayan sırt-karın ağrısı ve senkop hissi vardır.

Kanıt 2: Hasta hipotansif ve taşikardiktir.

Kanıt 3: Batında pulsatil kitle ve geniş aort anevrizması saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağı yerine geçmez.

Exam Pearl: Rüptüre abdominal aort anevrizması şüphesinde stabilizasyonla birlikte acil onarım gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 223: v185-new-223-ates-sarilik-ve-sag-ust-kadran-agrisi

Başlık: Ateş, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Akut kolanjitte Charcot triadı ve biliyer drenaj gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, titreme, sarılık ve sağ üst kadran ağrısı nedeniyle başvuruyor. Safra taşı öyküsü vardır. Son 24 saatte üşüme-titrete, koyu idrar ve giderek artan halsizlik gelişmiştir.

Demografi: 69 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 39.1°C | Şok indeksi: 1,41 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ üst kadranda hassasiyet vardır.
- Skleralar ikteriktir.
- Hasta konfüzyona eğilimlidir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Total bilirubin

Etiket: Total bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Obstrüktif sarılığı destekler. | Sonuç yorumu: Obstrüktif sarılığı destekler. | Sonuç başlığı: Total bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Obstrüktif sarılığı destekler. | Satırlar: Total bilirubin / 6.8 mg/dL / 0.2-1.2 mg/dL / Obstrüktif sarılığı destekler.

Tetkik 2: Alkalen fosfataz

Etiket: Alkalen fosfataz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kolestatik paterni destekler. | Sonuç yorumu: Kolestatik paterni destekler. | Sonuç başlığı: Alkalen fosfataz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kolestatik paterni destekler. | Satırlar: Alkalen fosfataz / 420 U/L / 40-130 U/L / Kolestatik paterni destekler.

Tetkik 3: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Koledok dilatasyonu ve safra kesesi taşları izlendi. | Klinik anlam: Biliyer obstrüksiyon lehinedir. | Sonuç yorumu: Biliyer obstrüksiyon lehinedir. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Koledok dilatasyonu ve safra kesesi taşları izlendi. | Yorum: Biliyer obstrüksiyon lehinedir. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Koledok dilatasyonu ve safra kesesi taşları izlendi. // Biliyer obstrüksiyon lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-118 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Koledok dilatasyonu ve safra kesesi taşları izlendi. | Klinik anlam: Biliyer obstrüksiyon lehinedir. | URL: https://iukbtikzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/118_koledok_dilatasyonu_kolelitiiazis_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/118_koledok_dilatasyonu_kolelitiiazis_usg.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Koledok dilatasyonu ve safra kesesi taşları izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada antibiyotik ve sıvı resüsitasyonuna ek olarak en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil ERCP ile biliyer drenaj
B) Elektif kolonoskopi
C) Oral analjezik tedavi ve ayakta izlem

D) Rutin proton pompa inhibitörü tedavisi

E) Acil splenektomi

Doğru Cevap: Acil ERCP ile biliyer drenaj

A) Acil ERCP ile biliyer drenaj: Acil ERCP ile biliyer drenaj ağır akut kolanjitte enfekte obstrükte safra yolunun kaynak kontrolünü sağlar. Vakadaki "Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır." ve "Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Elektif kolonoskopi: Vakadaki Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır ve Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır. Bu olguda "Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır." ve "Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ERCP ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Oral analjezik tedavi ve ayaktan izlem: Vakadaki Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır ve Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır. Bu olguda "Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır." ve "Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ERCP ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Rutin proton pompa inhibitörü tedavisi: Proton pompa inhibitörü mide asit ilişkili hastalıkta kullanılır; kolanjitte kaynak kontrolü sağlamaz. Bu olguda "Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır." ve "Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ERCP ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Acil splenektomi: Vakadaki Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır ve Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır. Bu olguda "Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır." ve "Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil ERCP ile biliyer drenaj seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır." ve "Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır." birlikte okunduğunda Acil ERCP ile biliyer drenaj seçeneği öne çıkar; "Ultrasonografide koledok dilatasyonu ve taşlar izlenmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, sağ üst kadranda ağrı, sarılık, hipotansiyon ve bilinç değişikliği ağır akut kolanjiti düşündürür. Antibiyotik ve resüsitasyona ek olarak obstrüksiyonun kaynak kontrolü için acil ERCP ile biliyer drenaj gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır.", "Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır." ve "Ultrasonografide koledok dilatasyonu ve taşlar izlenmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil ERCP ile biliyer drenaj en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ateş, sarılık ve sağ üst kadranda ağrı vardır.

Kanıt 2: Hipotansiyon ve konfüzyon ağır enfeksiyon bulgularıdır.

Kanıt 3: Ultrasonografide koledok dilatasyonu ve taşlar izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Akut kolanjitte antibiyotik yeterli değildir; obstrüksiyon varsa ERCP ile drenaj gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 224: v185-new-224-ani-epigastrik-agri-ve-tahta-karin

Başlık: Ani epigastrik ağrı ve tahta karın

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Perfore peptik ülserde serbest hava ve peritonit bulgularıyla acil cerrahiye seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan şiddetli epigastrik ağrı nedeniyle acile başvuruyor. Uzun süredir nonsteroid antiinflatamatuvar ilaç kullandığı ve son haftalarda dispepsi yakınmaları olduğu öğreniliyor. Ağrı aniden başlamış ve kısa sürede tüm karına yayılmıştır.

Demografi: 58 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 98/62 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 1,20 (yüksek)

Fizik Muayene

- Batın yaygın hassas, defanslı ve rijittir.
- Hasta hareketsiz yatmayı tercih etmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ayakta akciğer grafisi

Etiket: Ayakta akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Diyafram altında serbest hava izlendi. | Klinik anlam: İçi boş organ perforasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: İçi boş organ perforasyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Ayakta akciğer grafisi | Sonuç özeti: Diyafram altında serbest hava izlendi. | Yorum: İçi boş organ perforasyonunu destekler. | Satırlar: Ayakta akciğer grafisi / Diyafram altında serbest hava izlendi. // İçi boş organ perforasyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-119 | Başlık: Ayakta akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Diyafram altında serbest hava izlendi. | Klinik anlam: İçi boş organ perforasyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/119_diyafam_alti_serbest_hava_akciger_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/119_diyafam_alti_serbest_hava_akciger_grafisi.webp | Alt text: Ayakta akciğer grafisi - Diyafram altında serbest hava izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı

B) Oral antiasit verilmesi

C) Elektif endoskopi randevusu planlanması

D) Laksatif başlanması

E) Ayaktan antibiyotiksiz izlem

Doğru Cevap: Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı

A) Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı: Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı peritonit ve serbest hava bulunan hastada doğru yaklaşımdır. Vakadaki "Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır." ve "Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Oral antiasit verilmesi: Vakadaki Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır ve Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır. Bu olguda "Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır." ve "Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Elektif endoskopi randevusu planlanması: Elektif endoskopi acil peritonit tablosunda tedaviyi geciktirir ve perforasyon varlığında risklidir. Bu olguda "Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır." ve "Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Laksatif başlanması: Vakadaki Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır ve Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır. Bu olguda "Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır." ve "Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ayaktan antibiyotiksiz izlem: Vakadaki Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır ve Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır. Bu olguda “Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır.” ve “Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani epigastrik ağrı ve tahta karın olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır.” ve “Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır.” birlikte okunduğunda Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı seçeneği öne çıkar; “Grafide diyafram altında serbest hava izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ani başlayan epigastrik ağrı, yaygın peritonit bulguları ve diyafram altında serbest hava perfore peptik ülseri düşündürür. Bu durumda resüsitasyon, geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi değerlendirme gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır.”, “Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır.” ve “Grafide diyafram altında serbest hava izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil cerrahi değerlendirme, resüsitasyon ve perforasyon onarımı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ağrı ani başlamış ve tüm karına yayılmıştır.

Kanıt 2: Muayenede yaygın defans ve rijidite vardır.

Kanıt 3: Grafide diyafram altında serbest hava izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Tahta karın ve serbest hava içi boş organ perforasyonudur; acil cerrahi gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 225: v185-new-225-gebelikte-agrili-kanama

Başlık: Gebelikte ağrılı kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Ablatio plasentada klinik bulgularla acil obstetrik yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan karın ağrısı ve vajinal kanama nedeniyle başvuruyor. Hipertansiyon öyküsü vardır. Kanamanın koyu renkli olduğu, karın ağrısının sürekli ve şiddetli seyrettiği öğreniliyor. Fetal hareketlerde azalma tariflemektedir.

Demografi: 34 yaşında gebe hasta | Setting: Doğum acil ünitesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 158/96 mmHg | Nabız: 116/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,73

Fizik Muayene

- Uterus sert ve hassastır.
- Vajinal kanama koyu renklidir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fibrinojen

Etiket: Fibrinojen | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Tüketim koagülopatisi riskini destekler. | Sonuç yorumu: Tüketim koagülopatisi riskini destekler. | Sonuç başlığı: Fibrinojen | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Tüketim koagülopatisi riskini destekler. | Satırlar: Fibrinojen / 170 mg/dL / Gebelikte genellikle >300 mg/dL / Tüketim koagülopatisi riskini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ablatio plasenta
- B) Plasenta previa
- C) Vasa previa
- D) Molar gebelik
- E) Servikal polip

Doğru Cevap: Ablatio plasenta

A) Ablatio plasenta: Ablatio plasenta ağrılı koyu kanama, uterin sertlik ve fetal distress bulgularıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Kanama ağrılı ve koyu renklidir.” ve “Uterus sert ve hassastır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Plasenta previa: Vakadaki Kanama ağrılı ve koyu renklidir ve Uterus sert ve hassastır. Bu olguda “Kanama ağrılı ve koyu renklidir.” ve “Uterus sert ve hassastır.” ipuçları tanısal karar açısından Ablatio plasenta seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Vasa previa: Vasa previa membran rüptürü sonrası fetal kanama ve ani fetal distressle düşünülür; maternal uterin hassasiyet ön planda değildir. Bu olguda “Kanama ağrılı ve koyu renklidir.” ve “Uterus sert ve hassastır.” ipuçları tanısal karar açısından Ablatio plasenta seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Molar gebelik: Vakadaki Kanama ağrılı ve koyu renklidir ve Uterus sert ve hassastır. Bu olguda “Kanama ağrılı ve koyu renklidir.” ve “Uterus sert ve hassastır.” ipuçları tanısal karar açısından Ablatio plasenta seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Servikal polip: Servikal polip hafif temas kanaması yapabilir; fetal distress ve sert uterus tablosunu açıklamaz. Bu olguda “Kanama ağrılı ve koyu renklidir.” ve “Uterus sert ve hassastır.” ipuçları tanısal karar açısından Ablatio plasenta seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte ağrılı kanama olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Kanama ağrılı ve koyu renklidir.” ve “Uterus sert ve hassastır.” birlikte okunduğunda Ablatio plasenta seçeneği öne çıkar; “Fetal kalp hızı izlemi fetal distressi göstermektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağrılı koyu vajinal kanama, uterin sertlik-hassasiyet, hipertansiyon, fetal distress ve düşük fibrinojen ablatio plasentayı düşündürür. Plasenta previa genellikle ağrısız parlak kırmızı kanama ile seyreder. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama ağrılı ve koyu renklidir.”, “Uterus sert ve hassastır.” ve “Fetal kalp hızı izlemi fetal distressi göstermektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ablatio plasenta en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanama ağrılı ve koyu renklidir.

Kanıt 2: Uterus sert ve hassastır.

Kanıt 3: Fetal kalp hızı izlemi fetal distresi göstermektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Ağrılı kanama ve sert hassas uterus ablatio plasenta için tipiktir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 226: v185-new-226-gebelikte-bas-agrisi-ve-hipertansiyon

Başlık: Gebelikte baş ağrısı ve hipertansiyon

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Preeklampside ağır özellikleri tanıyıp magnezyum sülfat kullanımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı ve el-yüz şişliği nedeniyle başvuruyor. Son haftalarda tansiyon yüksekliği saptandığı, bugün baş ağrısı ve göz önünde ışık çakmaları geliştiği öğreniliyor. Epigastrik ağrı da tariflemektedir.

Demografi: 31 yaşında gebe hasta | Setting: Doğum acil ünitesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 168/112 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,57

Fizik Muayene

- Yüz ve ellerde ödem vardır.
- Derin tendon refleksleri canlıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar protein/kreatinin oranı

Etiket: İdrar protein/kreatinin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Proteinüriyi destekler. | Sonuç yorumu: Proteinüriyi destekler. | Sonuç başlığı: İdrar protein/kreatinin oranı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Proteinüriyi destekler. | Satırlar: İdrar protein/kreatinin oranı / 0.8 / <0.3 / Proteinüriyi destekler.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Ağır özellik göstergesidir. | Sonuç yorumu: Ağır özellik göstergesidir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Ağır özellik göstergesidir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 92000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Ağır özellik göstergesidir.

Tetkik 3: AST

Etiket: AST | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Karaciğer etkilenimini destekler. | Sonuç yorumu: Karaciğer etkilenimini destekler. | Sonuç başlığı: AST | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Karaciğer etkilenimini destekler. | Satırlar: AST / 98 U/L / <35 U/L / Karaciğer etkilenimini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada konvülsiyon profilaksisi için başlanması gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Magnezyum sülfat
B) Metotreksat
C) Oksitosin
D) Ergometrin
E) Klomifen sitrat

Doğru Cevap: Magnezyum sülfat

- A) Magnezyum sülfat: Magnezyum sülfat ağır preeklampside eklampsi nöbetini önlemek için uygun tedavidir. Vakadaki “Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Metotreksat: Vakadaki Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir ve Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir. Bu olguda “Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Oksitosin: Oksitosin doğum indüksiyonu veya postpartum uterin atoni tedavisinde kullanılır; nöbet profilaksisi değildir. Bu olguda “Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ergometrin: Ergometrin uterotoniktir ve hipertansiyonu kötüleştirir; preeklampside uygun nöbet profilaksisi değildir. Bu olguda “Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Klomifen sitrat: Klomifen sitrat ovulasyon indüksiyonunda kullanılır; gebelikte ağır preeklampsi tedavisi değildir. Bu olguda “Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte baş ağrısı ve hipertansiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.” ve “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.” birlikte okunduğunda Magnezyum sülfat seçeneği öne çıkar; “Proteinüri, trombositopeni ve AST yüksekliği eşlik etmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Şiddetli hipertansiyon, baş ağrısı, görme bulguları, proteinüri, trombositopeni ve karaciğer enzim yüksekliği ağır özellikli preeklampsiyi düşündürür. Eklampsi nöbetini önlemek için magnezyum sülfat başlanır; kan basıncı kontrolü ve doğum zamanlaması ayrıca planlanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.”, “Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.” ve “Proteinüri, trombositopeni ve AST yüksekliği eşlik etmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Magnezyum sülfat en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kan basıncı ağır hipertansiyon düzeyindedir.

Kanıt 2: Baş ağrısı ve görme bulanıklığı nörolojik ağır özelliklerdir.

Kanıt 3: Proteinüri, trombositopeni ve AST yüksekliği eşlik etmektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ağır preeklampside nöbet profilaksisi için magnezyum sülfat kullanılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 227: v185-new-227-ani-pelvik-agri-ve-over-kisti

Başlık: Ani pelvik ağrı ve over kisti

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Over torsiyonunda ani pelvik ağrı ve Doppler bulgularıyla acil cerrahi yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan şiddetli sol alt kadranda ağrısı ve kusma nedeniyle başvuruyor. Daha önce sol overde kist izlendiği öğreniliyor. Ağrı aniden başlamış, dalgalar halinde şiddetlenmiş ve bulantı-kusma eşlik etmiştir. Gebelik testi evde negatif çıkmıştır.

Demografi: 24 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.2°C | Şok indeksi: 1,00 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sol alt kadranda ve adneksiyel bölgede belirgin hassasiyet vardır.
- Peritonit bulgusu belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum beta-hCG

Etiket: Serum beta-hCG | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Negatif saptandı. | Klinik anlam: Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter. | Sonuç yorumu: Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter. | Sonuç başlığı: Serum beta-hCG | Sonuç özeti: Negatif saptandı. | Yorum: Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter. | Satırlar: Serum beta-hCG / Negatif saptandı. // Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter.

Tetkik 2: Transvajinal Doppler ultrasonografi

Etiket: Transvajinal Doppler ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol over büyümüş, periferik foliküller izlenmiş ve venöz akım belirgin azalmış saptandı. | Klinik anlam: Over torsiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Over torsiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Transvajinal Doppler ultrasonografi | Sonuç özeti: Sol over büyümüş, periferik foliküller izlenmiş ve venöz akım belirgin azalmış saptandı. | Yorum: Over torsiyonunu destekler. | Satırlar: Transvajinal Doppler ultrasonografi / Sol over büyümüş, periferik foliküller izlenmiş ve venöz akım belirgin azalmış saptandı. // Over torsiyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-120 | Başlık: Transvajinal Doppler ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sol over büyümüş, periferik foliküller izlenmiş ve venöz akım belirgin azalmış saptandı. | Klinik anlam: Over torsiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/120_over_torsiyonu_doppler_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/120_over_torsiyonu_doppler_usg.webp | Alt text: Transvajinal Doppler ultrasonografi - Sol over büyümüş, periferik foliküller izlenmiş ve venöz akım belirgin azalmış saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon
- B) Oral analjezik ve poliklinik kontrolü
- C) Metotreksat tedavisi
- D) Geniş spektrumlu antibiyotikle ayaktan izlem
- E) Elektif smear takibi

Doğru Cevap: Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon

A) Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon: Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon over torsiyonunda over canlılığını korumak için doğru yaklaşımdır. Vakadaki "Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir." ve "Bilinen over kisti öyküsü vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Oral analjezik ve poliklinik kontrolü: Vakadaki Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir ve Bilinen over kisti öyküsü vardır. Bu olguda "Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir." ve "Bilinen over kisti öyküsü vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Metotreksat tedavisi: Metotreksat ektopik gebelik tedavisinde kullanılır; beta-hCG negatif ve torsiyon bulguları olan bu hastaya uygun değildir. Bu olguda "Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir." ve "Bilinen over kisti öyküsü vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Geniş spektrumlu antibiyotikle ayaktan izlem: Vakadaki Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir ve Bilinen over kisti öyküsü vardır. Bu olguda "Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir." ve "Bilinen over kisti öyküsü vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Elektif smear takibi: Vakadaki Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir ve Bilinen over kisti öyküsü vardır. Bu olguda "Ağrı ani başlamış ve Bilinen over kisti öyküsü vardır." ve "Bilinen over kisti öyküsü vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani pelvik ağrı ve over kisti olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir." ve "Bilinen over kisti öyküsü vardır." birlikte okunduğunda Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon seçeneği öne çıkar; "Doppler ultrasonografide büyümüş over ve venöz akım azalması saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ani şiddetli unilateral pelvik ağrı, kusma, bilinen over kisti ve Doppler'de venöz akım azalması over torsiyonunu düşündürür. Over canlılığını korumak için acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir.", "Bilinen over kisti öyküsü vardır." ve "Doppler ultrasonografide büyümüş over ve venöz akım azalması saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil laparoskopik değerlendirme ve detorsiyon en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ağrı ani başlamış ve unilateral pelvik bölgededir.

Kanıt 2: Bilinen over kisti öyküsü vardır.

Kanıt 3: Doppler ultrasonografide büyümüş over ve venöz akım azalması saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Over torsiyonu zaman kritik cerrahi acildir; Doppler normal olsa bile güçlü klinik şüphe cerrahiyi gerektirebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 228: v185-new-228-ani-konusma-bozuklugu-ve-kol-gucsuzlugu

Başlık: Ani konuşma bozukluğu ve kol güçsüzlüğü

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Akut iskemik inmede tromboliz öncesi kontrastsız beyin BT gerekliliğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan konuşma bozukluğu ve sağ kol güçsüzlüğü nedeniyle getiriliyor. Yakınları semptomların 90 dakika önce başladığını, hastanın aniden kelimeleri çıkaramadığını ve sağ kolunu kaldıramadığını belirtmektedir. Antikoagülan kullanımı bilinmemektedir.

Demografi: 67 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 164/92 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,54

Fizik Muayene

- Afazi ve sağ üst ekstremitede belirgin güçsüzlük vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada reperfüzyon tedavisi kararı öncesi ilk yapılması gereken görüntüleme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi
- B) Elektif elektroensefalografi
- C) Direkt servikal grafi
- D) Rutin lomber ponksiyon
- E) Ayaktan kraniyal ultrasonografi

Doğru Cevap: Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi

A) Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi: Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi tromboliz öncesi intrakraniyal kanamayı dışlamak için ilk gerekli görüntülemedir. Vakadaki "Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur." ve "Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Elektif elektroensefalografi: Elektroensefalografi nöbet değerlendirmesinde kullanılabilir ancak akut tromboliz kararı için ilk görüntüleme değildir. Bu olguda "Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur." ve "Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Direkt servikal grafi: Vakadaki Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur ve Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir. Bu olguda "Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur." ve "Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Rutin lomber ponksiyon: Lomber ponksiyon seçilmiş subaraknoid kanama şüphesinde düşünülebilir; akut inme tromboliz kararında ilk basamak değildir. Bu olguda "Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur." ve "Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ayaktan kraniyal ultrasonografi: Vakadaki Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur ve Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir. Bu olguda "Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur." ve "Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir." ipuçları tedavi önceliği açısından Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani konuşma bozukluğu ve kol güçsüzlüğü olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur." ve "Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir." birlikte okunduğunda Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi seçeneği öne çıkar; "Kan glukozu hipoglisemi taklidini dışlayacak düzeydedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Akut fokal nörolojik defisit ve kısa semptom süresi iskemik inme olasılığını düşündürür. Trombolitik tedavi düşünülmenden önce intrakraniyal kanamayı dışlamak için kontrastsız beyin BT çekilmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur.", "Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir." ve "Kan glukozu hipoglisemi taklidini dışlayacak düzeydedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kontrastsız beyin bilgisayarlı tomografisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Semptomlar ani başlamış ve 90 dakika içinde başvurmuştur.

Kanıt 2: Afazi ve sağ kol güçsüzlüğü fokal nörolojik defisittir.

Kanıt 3: Kan glukozu hipoglisemi taklidini dışlayacak düzeydedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Akut inmede tromboliz öncesi ilk kritik adım kanamayı dışlayan kontrastsız beyin BT'dir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 229: v185-new-229-antidepresan-sonrasi-ajitasyon-ve-klonus

Başlık: Antidepresan sonrası ajitasyon ve klonus

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Serotonin sendromunu ilaç etkileşimi, otonom ve nöromusküler bulgularla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ajitasyon, terleme, ishal ve titreme nedeniyle acile getiriliyor. Majör depresyon nedeniyle SSRI kullandığı, son günlerde migren için triptan aldığı öğreniliyor. Yakınmaları ilaç kullanımından sonra aynı gün içinde başlamıştır.

Demografi: 28 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 154/92 mmHg | Nabız: 126/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.5°C | Şok indeksi: 0,82

Fizik Muayene

- Hasta ajite ve terlidir.
- Alt ekstremitelerde hiperrefleksi ve spontan klonus izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Serotonin sendromu
- B) Nöroleptik malign sendrom
- C) Malign hipertermi
- D) Opioid intoksikasyonu
- E) Alkol yoksunluğu deliryumu

Doğru Cevap: Serotonin sendromu

A) Serotonin sendromu: Serotonin sendromu serotonerjik ilaç kombinasyonu sonrası hızlı başlayan otonom bulgular, ishal, hiperrefleksi ve klonusla en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır." ve "Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Nöroleptik malign sendrom: Nöroleptik malign sendrom dopamin blokajı sonrası daha yavaş gelişir ve kurşun boru rijiditesi ön plandadır. Bu olguda "Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır." ve "Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır." ipuçları tanısal karar açısından Serotonin sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Malign hipertermi: Malign hipertermi anestezik tetikleyicilerle gelişir; bu hastada serotonerjik ilaç etkileşimi vardır. Bu olguda "Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır." ve "Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır." ipuçları tanısal karar açısından Serotonin sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Opioid intoksikasyonu: Opioid intoksikasyonunda miyozis, solunum depresyonu ve bilinç baskılanması beklenir; klonus tipik değildir. Bu olguda "Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır." ve "Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır." ipuçları tanısal karar açısından Serotonin sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Alkol yoksunluğu deliryumu: Alkol yoksunluğu deliryumu tremor ve ajitasyon yapabilir ancak serotonerjik ilaç kombinasyonu ve klonus daha açıklayıcıdır. Bu olguda "Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır." ve "Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır." ipuçları tanısal karar açısından Serotonin sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antidepresan sonrası ajitasyon ve klonus olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır." ve "Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır." birlikte okunduğunda Serotonin sendromu seçeneği öne çıkar; "Hiperrefleksi ve spontan klonus vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: SSRI ve triptan kombinasyonu sonrası saatler içinde ajitasyon, hipertermi, hipertansiyon, terleme, ishal, hiperrefleksi ve klonus gelişmesi serotonin sendromunu düşündürür. Nöromusküler hiperaktivite özellikle klonus ayırıcı tanıda önemlidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır.", "Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır." ve "Hiperrefleksi ve spontan klonus vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Serotonin sendromu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta SSRI kullanırken triptan almıştır.

Kanıt 2: Yakınmalar ilaç etkileşiminden sonra hızlı başlamıştır.

Kanıt 3: Hiperrefleksi ve spontan klonus vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Serotonin sendromunda klonus ve hiperrefleksi; nöroleptik malign sendromda rijidite daha belirgindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 230: v185-new-230-atesli-agrili-diz-sisligi

Başlık: Ateşli agrili diz şişliği

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Septik artritte akut monoartrit bulgularıyla eklem aspirasyonu ve antibiyotik yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ dizde ani başlayan şiddetli ağrı, şişlik ve ateş nedeniyle başvuruyor. Bir gün içinde diz ağrısının hızla arttığını ve üzerine basamadığını belirtmektedir. Diyabet öyküsü vardır. Travma tariflemiyor.

Demografi: 39 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.7°C | Şok indeksi: 1,27 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ diz belirgin şiş, sıcak ve hareketle çok ağrılıdır.
- Eklem hareket açıklığı belirgin kısıtlıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyaz küre sayısı

Etiket: Beyaz küre sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Akut enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Beyaz küre sayısı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut enfeksiyon olasılığını destekler. | Satırlar: Beyaz küre sayısı / 17200 /mm³ / 4500-11000 /mm³ / Akut enfeksiyon olasılığını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun ilk tanısal ve tedaviye yön veren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak
B) Nonsteroid antiinflamatuvar vererek ayakta izlem planlamak
C) Elektif manyetik rezonans randevusu izlem planlamak
D) Eklem içine steroid enjeksiyonu yapmak
E) Gut diyeti önermek

Doğru Cevap: Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak

A) Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak: Acil artrosentez ve ampirik antibiyotik septik artritte tanıyı doğrulayan ve eklem hasarını önleyen doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.” ve “Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Nonsteroid antiinflamatuvar vererek ayakta izlem planlamak: Nonsteroid antiinflamatuvar vererek ayakta izlem planlamak, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda “Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.” ve “Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Elektif manyetik rezonans randevusu izlem planlamak: Elektif manyetik rezonans randevusu izlem planlamak, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda “Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.” ve “Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Eklem içine steroid enjeksiyonu yapmak: Vakadaki Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir ve Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır. Bu olguda “Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.” ve “Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Gut diyeti önermek: Gut diyeti önermek, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda “Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.” ve “Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateşli ağrılı diz şişliği olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.” ve “Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.” birlikte okunduğunda Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak seçeneği öne çıkar; “Ateş ve lökositoz enfeksiyon olasılığını desteklemektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, akut monoartrit, şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve diyabet septik artrit olasılığını artırır. Eklem hasarını önlemek için acil artrosentezle sinovyal sıvı analizi ve kültür alınmalı, ardından ampirik antibiyotik başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.”, “Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.” ve “Ateş ve lökositoz enfeksiyon olasılığını desteklemektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil artrosentez yapıp sinovyal sıvı analizi-kültürü almak ve ampirik antibiyotik başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Diz ağrısı ve şişliği akut başlamış ve hızla kötüleşmiştir.

Kanıt 2: Eklem sıcak, şiş ve hareketle çok ağrılıdır.

Kanıt 3: Ateş ve lökositoz enfeksiyon olasılığını desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Septik artrit ortopedik acildir; eklem aspirasyonu ve antibiyotik gecikmemelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 231: v186-new-231-gebeligin-son-doneminde-agrisiz-kanama

Başlık: Gebeliğin son döneminde ağrısız kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Plasenta previa da ağrısız üçüncü trimester kanamasını tanıyıp vajinal muayeneden kaçınmayı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan parlak kırmızı vajinal kanama nedeniyle başvuruyor. Kanamanın ağrısız başladığını, karın ağrısı veya düzenli kasılma hissetmediğini belirtmektedir. Daha önce sezaryen doğum öyküsü vardır. Fetal hareketleri hissetmektedir.

Demografi: 32 yaşında gebe hasta | Setting: Doğum acil ünitesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 94/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,84

Fizik Muayene

- Genel durumu stabildir.
- Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.
- Vajinal kanama parlak kırmızı renktedir.
- Dijital vajinal muayene yapılmamıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Transabdominal ultrasonografi

Etiket: Transabdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Plasentanın internal servikal osu örttüğü izlendi. | Klinik anlam: Plasenta previa lehinedir. | Sonuç yorumu: Plasenta previa lehinedir. | Sonuç başlığı: Transabdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Plasentanın internal servikal osu örttüğü izlendi. | Yorum: Plasenta previa lehinedir. | Satırlar: Transabdominal ultrasonografi / Plasentanın internal servikal osu örttüğü izlendi. // Plasenta previa lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-121 | Başlık: Transabdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Plasentanın internal servikal osu örttüğü izlendi. | Klinik anlam: Plasenta previa lehinedir. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/121_plasenta_previa_ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/121_plasenta_previa_ultrasonografi.webp | Alt text: Transabdominal ultrasonografi - Plasentanın internal servikal osu örttüğü izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk yaklaşım açısından en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dijital vajinal muayene ile servikal açıklığı değerlendirmek
- B) Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak
- C) Ağrısız kanama nedeniyle ayaktan izlem planlamak
- D) Uterin masaj ve metilergonovin uygulamak
- E) Amniyotomi yaparak doğumu hızlandırmak

Doğru Cevap: Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak

A) Dijital vajinal muayene ile servikal açıklığı değerlendirmek: Dijital vajinal muayene plasenta previa varlığında masif kanamayı tetikleyebileceği için uygun ilk yaklaşım değildir. Bu olguda “Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.” ve “Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak: Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak plasenta previa şüphesinde doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.” ve “Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Ağrısız kanama nedeniyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır ve Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir. Bu olguda “Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.” ve “Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Uterin masaj ve metilergonovin uygulamak: Uterin masaj ve metilergonovin postpartum uterin atoni kanamasında düşünülür; antepartum plasenta previa kanamasını tedavi etmez. Bu olguda “Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.” ve “Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Amniyotomi yaparak doğumu hızlandırmak: Vakadaki Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır ve Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir. Bu olguda “Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.” ve “Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebeliğin son döneminde ağrısız kanama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.” ve “Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.” birlikte okunduğunda Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide plasenta internal servikal osu örtmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Üçüncü trimesterde ağrısız parlak kırmızı vajinal kanama, yumuşak-hassasiyetsiz uterus ve geçirilmiş sezaryen öyküsü plasenta previaı düşündürür. Plasenta previa dışlanmadan dijital vajinal muayene yapılması masif kanamayı tetikleyebilir; ilk değerlendirme ultrasonografiyle plasenta yerleşimini belirlemektir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.”, “Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.” ve “Ultrasonografide plasenta internal servikal osu örtmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ultrasonografi ile plasenta yerleşimini değerlendirmek ve dijital muayeneden kaçınmak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanama üçüncü trimesterde ağrısız ve parlak kırmızı renkte başlamıştır.

Kanıt 2: Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.

Kanıt 3: Ultrasonografide plasenta internal servikal osu örtmektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Üçüncü trimester ağrısız kanamasında plasenta previa dışlanmadan dijital vajinal muayene yapılmaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 232: v186-new-232-gebelikte-nobet-ve-hipertansiyon

Başlık: Gebelikte nöbet ve hipertansiyon

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Eklampside nöbet tedavisinde magnezyum sülfatın önceliğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, evde jeneralize nöbet geçirmesi sonrası acile getiriliyor. Son günlerde şiddetli baş ağrısı, görme bulanıklığı ve yüzünde şişlik olduğu öğreniliyor. Daha önce epilepsi tanısı yoktur. Gebelik takiplerinde tansiyon yüksekliği saptanmıştır.

Demografi: 27 yaşında gebe hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 176/114 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,61

Fizik Muayene

- Hasta postiktal dönemde uykuya eğilimlidir.
- Yüz ve ellerde ödem vardır.
- Derin tendon refleksleri artmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar protein/kreatinin oranı

Etiket: İdrar protein/kreatinin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Proteinüriyi destekler. | Sonuç yorumu: Proteinüriyi destekler. | Sonuç başlığı: İdrar protein/kreatinin oranı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Proteinüriyi destekler. | Satırlar: İdrar protein/kreatinin oranı / 1.1 / <0.3 / Proteinüriyi destekler.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Ağır özellikleri destekler. | Sonuç yorumu: Ağır özellikleri destekler. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Ağır özellikleri destekler. | Satırlar: Trombosit sayısı / 98000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Ağır özellikleri destekler.

Görseller

Bu vaka için bağılı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada nöbet kontrolü ve tekrarını önlemek için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Diazepam ile kontrol tedavisi olarak idame tedavisi
B) Magnezyum sülfat verilmesi
C) Metotreksat başlanması
D) Oksitosin infüzyonu başlanması
E) Kломifen sitrat verilmesi

Doğru Cevap: Magnezyum sülfat verilmesi

A) Diazepam ile kontrol tedavisi olarak idame tedavisi: Vakadaki Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır ve Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir. Bu olguda “Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.” ve “Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Magnezyum sülfat verilmesi: Magnezyum sülfat eklampside nöbet kontrolü ve profilaksisi için doğru tedavidir. Vakadaki “Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.” ve “Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Metotreksat başlanması: Vakadaki Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır ve Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir. Bu olguda “Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.” ve “Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oksitosin infüzyonu başlanması: Vakadaki Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır ve Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir. Bu olguda “Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.” ve “Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kломifen sitrat verilmesi: Vakadaki Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır ve Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir. Bu olguda “Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.” ve “Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Magnezyum sülfat verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gebelikte nöbet ve hipertansiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.” ve “Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.” birlikte okunduğunda Magnezyum sülfat verilmesi seçeneği öne çıkar; “Proteinüri ve trombositopeni preeklampitik zemini destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gebelikte hipertansiyon, proteinüri, nörolojik semptomlar ve jeneralize nöbet eklampsisi gösterir. Eklampside nöbet tedavisi ve profilaksisinde ilk tercih magnezyum sülfattır; kan basıncı kontrolü ve doğum planı ayrıca yapılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.”, “Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.” ve “Proteinüri ve trombositopeni preeklampitik zemini destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Magnezyum sülfat verilmesi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada gebelik sırasında ağır hipertansiyon vardır.

Kanıt 2: Nöbet öncesinde baş ağrısı ve görme bulanıklığı tariflenmiştir.

Kanıt 3: Proteinüri ve trombositopeni preeklampitik zemini destekler.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Eklampside nöbet için temel ilaç magnezyum sülfattır; klasik antiepileptikler ilk tercih değildir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 233: v186-new-233-ani-gorme-alani-kaybi

Başlık: Ani görme alanı kaybı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Retina dekolmanında ışık çakması ve perde inmesi bulgularıyla acil oftalmoloji yönlendirmesini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ gözde ışık çakmaları ve görme alanında perde inmesi hissi nedeniyle başvuruyor. Son iki gündür uçuşan siyah noktalar gördüğünü, bugün sağ gözün üst-dış görme alanından başlayarak koyu bir perdenin indiğini belirtmektedir. Ağrı veya kızarıklık tariflememektedir. Yüksek miyopi öyküsü vardır.

Demografi: 59 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servisi

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ gözde dış görünüm sakın ve ağrısızdır.
- Pupil ışık reaksiyonu korunmuştur.
- Görme alanı muayenesinde sağ gözde periferik defekt izlenir.
- Göz içi basıncı normaldir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Dilate fundus muayenesi

Etiket: Dilate fundus muayenesi | Tip: Iab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Periferik retinada yırtık ve elevasyonla uyumlu alan izlendi. | Klinik anlam: Retina dekolmanını destekler. | Sonuç yorumu: Retina dekolmanını destekler. | Sonuç başlığı: Dilate fundus muayenesi | Sonuç özeti: Periferik retinada yırtık ve elevasyonla uyumlu alan izlendi. | Yorum: Retina dekolmanını destekler. | Satırlar: Dilate fundus muayenesi / Periferik retinada yırtık ve elevasyonla uyumlu alan izlendi. // Retina dekolmanını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-122 | Başlık: Dilate fundus muayenesi | Modalite: ophthalmology | Bulgu: Periferik retinada yırtık ve elevasyonla uyumlu alan izlendi. | Klinik anlam: Retina dekolmanını destekler. | URL: https://iukbtikzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/122_retina_dekolmani_fundus.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/122_retina_dekolmani_fundus.webp | Alt text: Dilate fundus muayenesi - Periferik retinada yırtık ve elevasyonla uyumlu alan izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut aç ı kapanması glokomu
B) Optik nör it
C) Retina dekolmanı
D) Viral konjonktivit
E) Hordeolum

Doğ ru Cevap: Retina dekolmanı

A) Akut aç ı kapanması glokomu: Akut aç ı kapanması glomunda ş iddetli ağ rı, kırmızı göz, korneal bulanıklık ve yüksek göz iç i basıncı beklenir. Bu olguda “Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.” ve “Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.” ipuç ları tanısal karar aç ısından Retina dekolmanı seç eneg ini daha güçlü kılar.

B) Optik nör it: Optik nör it genellikle göz hareketiyle ağ rı ve santral görme kayb ı yapar; fundusta yırtık ve elevasyon beklenmez. Bu olguda “Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.” ve “Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.” ipuç ları tanısal karar aç ısından Retina dekolmanı seç eneg ini daha güçlü kılar.

C) Retina dekolmanı: Retina dekolmanı ış ık ç akması, uç uş an cisimler, perde inmesi ve retinal yırtık bulgusuyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.” ve “Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.” ipuç ları birlikte değ erlendirildiğ inde bu seç enek klinik olarak gerekçelenir.

D) Viral konjonktivit: Viral konjonktivit kızarıklık ve sulanma yapar; ağ ırsız perde ş eklinde görme alan ı kayb ı oluşturmaz. Bu olguda “Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.” ve “Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.” ipuç ları tanısal karar aç ısından Retina dekolmanı seç eneg ini daha güçlü kılar.

E) Hordeolum: Hordeolum göz kapağ ında lokal ağ ırl ı nodüldür; retinal yırtık ve görme alan ı kayb ını açıklamaz. Bu olguda “Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.” ve “Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.” ipuç ları tanısal karar aç ısından Retina dekolmanı seç eneg ini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani görme alan ı kayb ı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.” ve “Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.” birlikte okunduğ unda Retina dekolmanı seç eneg i ö ne ç ıkar; “Fundus muayenesinde retinal yırtık ve elevasyon görülmüş tür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğ ini artırır.

Rationale: Iş ık ç akmaları, uç uş an cisimler, ağ ırsız görme alan ı kayb ı ve perde inmesi retina dekolman ını düş ündürür. Fundusta retinal yırtık ve elevasyon görülm esi tanıyı destekler ve acil oftalmolojik müdahale gerektirir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.”, “Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.” ve “Fundus muayenesinde retinal yırtık ve elevasyon görülmüş tür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Retina dekolmanı en tutarlı yanıt tır.

Kanıt 1: Hasta ış ık ç akmaları ve uç uş an siyah noktalar tariflemektedir.

Kanıt 2: Görme alanında perde inmesi ş eklinde ağ ırsız kayıp geliş miş tir.

Kanıt 3: Fundus muayenesinde retinal yırtık ve elevasyon görülmüş tür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine ö ykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşt urduğ u patern birlikte değ erlendirilmelidir. Ç eldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, ş iddet, zamanlama veya yönetim önceliğ i aç ısından doğ ru yanıt tıtan ayrılır.

Exam Pearl: Ağ ırsız perde inmesi ve ış ık ç akması retina dekolmanı için uyarıcıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğ ru cevap: Evet | Seç enek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 234: v186-new-234-sosyal-cekilme-ve-duygulanim-azalması

Başlık: Sosyal çekilme ve duygulanım azalması

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eş leştirme.

Learning Target: Psikotik bozuklukta negatif belirtileri depresyon ve ilaç yan etkilerinden ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ailesi tarafından konuşmasının azalması, sosyal çekilme ve kişisel bakımda bozulma nedeniyle getiriliyor. Son bir yıldır arkadaşlarıyla görüşmediğ i, okulunu bıraktığ ı ve gününün çoğ unu odasında geçirdiğ i öğreniliyor. Daha önce dönem dönem kendisine seslenen kişiler duyduğ unu söylemiş ancak son aylarda belirgin sanrı ya da halüsinasyon tariflememiş tir.

Demografi: 24 yaş ında erkek hasta | Setting: Klinik değ erlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Duygulanımı künt, konuşması fakirdir.
- Göz temas ı azdır.
- Belirgin psikomotor retardasyon yoktur.
- İntihar düş üncesi belirtmemektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağı lı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seç enekler / Feedback

Soru: Bu hastada ön planda olan belirti grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Manik belirtiler
B) Negatif psikotik belirtiler
C) Panik belirtileri
D) Obsesif-kompulsif belirtiler
E) Katatonik belirtiler

Doğ ru Cevap: Negatif psikotik belirtiler

A) Manik belirtiler: Manik belirtilerde taşkın duygudurum, uyku ihtiyac ında azalma ve artmış enerji beklenir; bu hastada çekilme ve duygulanım azalması vardır. Bu olguda “Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğ inde bozulma vardır.” ve “Konuşma fakirliğ i ve künt duygulanım izlenmektedir.” ipuç ları tanısal karar aç ısından Negatif psikotik belirtiler seç eneg ini daha güçlü kılar.

B) Negatif psikotik belirtiler: Negatif psikotik belirtiler sosyal çekilme, aloji, avolisyon ve künt duygulanım ile bu tabloyu en iyi açıklar. Vakadaki “Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğ inde bozulma vardır.” ve “Konuşma fakirliğ i ve künt duygulanım izlenmektedir.” ipuç ları birlikte değ erlendirildiğ inde bu seç enek klinik olarak gerekçelenir.

C) Panik belirtileri: Panik belirtileri ani yoğun kayg ı atakları ve otonom bulgularla seyred er; kronik sosyal çekilme paternini açıklamaz. Bu olguda “Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğ inde bozulma vardır.” ve “Konuşma fakirliğ i ve künt duygulanım izlenmektedir.” ipuç ları tanısal karar aç ısından Negatif psikotik belirtiler seç eneg ini daha güçlü kılar.

D) Obsesif-kompulsif belirtiler: Obsesif-kompulsif belirtilerde yineleyici düşünceler ve kompulsiyonlar beklenir; bu olguda temel bulgu negatif semptomlardır. Bu olguda “Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğinde bozulma vardır.” ve “Konuşma fakirliği ve künt duygulanım izlenmektedir.” ipuçları tanısallık açısından Negatif psikotik belirtiler seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Katatonik belirtiler: Katatonik belirtiler stupor, postür alma veya balmumu esnekliği gibi motor bulgularla ilişkilidir. Bu olguda “Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğinde bozulma vardır.” ve “Konuşma fakirliği ve künt duygulanım izlenmektedir.” ipuçları tanısallık açısından Negatif psikotik belirtiler seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sosyal çekilme ve duygulanım azalması olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. “Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğinde bozulma vardır.” ve “Konuşma fakirliği ve künt duygulanım izlenmektedir.” birlikte okunduğunda Negatif psikotik belirtiler seçeneği öne çıkar; “Son aylarda belirgin sanrı veya halüsinasyon tariflenmemektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sosyal çekilme, konuşma fakirliği, künt duygulanım, motivasyon azalması ve işlevsellikte bozulma şizofreni spektrumunda negatif belirtileri düşündürür. Aktif halüsinasyon ve sanrılar pozitif belirtilerdir; bu olguda mevcut tablo negatif belirtilerle daha uyumludur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğinde bozulma vardır.”, “Konuşma fakirliği ve künt duygulanım izlenmektedir.” ve “Son aylarda belirgin sanrı veya halüsinasyon tariflenmemektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Negatif psikotik belirtiler en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada sosyal çekilme ve okul işlevselliğinde bozulma vardır.

Kanıt 2: Konuşma fakirliği ve künt duygulanım izlenmektedir.

Kanıt 3: Son aylarda belirgin sanrı veya halüsinasyon tariflenmemektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Şizofrenide negatif belirtiler işlevselliği belirgin bozar ve pozitif belirtilerden farklı değerlendirilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 235: v186-new-235-uzayan-bogulur-tarzda-oksuruk

Başlık: Uzayan boğulur tarzda öksürük

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Bordetella pertussis enfeksiyonunda paroksizmal öksürük ve lenfositoz bulgularını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, haftalardır süren nöbetler halinde öksürük ve öksürük sonrası kusma nedeniyle getiriliyor. Aşılarının eksik olduğu öğreniliyor. Başlangıçta hafif burun akıntısı ve düşük ateş olduğu, ardından özellikle geceleri artan boğulur tarzda öksürük nöbetleri geliştiği belirtiliyor.

Demografi: 5 yaşında kız çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.2°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Muayene sırasında tekrarlayan paroksizmal öksürük ve inspiratuvar boğulur tarzda ses duyulur.
- Akciğer oskültasyonunda belirgin ral yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lenfositoz saptandı. | Klinik anlam: Boğmaca için destekleyici olabilir. | Sonuç yorumu: Boğmaca için destekleyici olabilir. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lenfositoz saptandı. | Yorum: Boğmaca için destekleyici olabilir. | Satırlar: Tam kan sayımı / 18500 /mm³ / Yaşa göre değişken / Boğmaca için destekleyici olabilir.

Tetkik 2: Nazofarengeal PCR

Etiket: Nazofarengeal PCR | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Bordetella pertussis pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni doğrular. | Sonuç yorumu: Etkeni doğrular. | Sonuç başlığı: Nazofarengeal PCR | Sonuç özeti: Bordetella pertussis pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni doğrular. | Satırlar: Nazofarengeal PCR / Bordetella pertussis pozitif saptandı. // Etkeni doğrular.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mycoplasma pneumoniae
- B) Bordetella pertussis
- C) Streptococcus pyogenes
- D) Corynebacterium diphtheriae
- E) Haemophilus influenzae tip b

Doğru Cevap: Bordetella pertussis

A) Mycoplasma pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae atipik pnömoni ve kuru öksürük yapabilir ancak inspiratuvar boğulur tarzda öksürük nöbeti ve PCR bulgusu Bordetella lehinedir. Bu olguda “Çocuğun aşıları eksiktir.” ve “Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısallık açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Bordetella pertussis: Bordetella pertussis eksik aşıli çocukta paroksizmal öksürük, öksürük sonrası kusma ve lenfositozla uyumlu etkindir. Vakadaki “Çocuğun aşıları eksiktir.” ve “Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Streptococcus pyogenes: Streptococcus pyogenes farenjit ve cilt enfeksiyonlarıyla ilişkilidir; boğmaca benzeri paroksizmal öksürük tipik değildir. Bu olguda “Çocuğun aşıları eksiktir.” ve “Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısallık açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Corynebacterium diphtheriae: Corynebacterium diphtheriae psödomembranlı farenjit ve toksin ilişkili komplikasyonlar yapar; bu tablo boğmacayla uyumludur. Bu olguda “Çocuğun aşıları eksiktir.” ve “Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısallık açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Haemophilus influenzae tip b: Haemophilus influenzae tip b epiglottit ve invaziv enfeksiyonlarla ilişkilidir; haftalar süren paroksizmal öksürük paternini açıklamaz. Bu olguda “Çocuğun aşıları eksiktir.” ve “Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ipuçları tanısallık açısından Bordetella pertussis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzayan boğulur tarzda öksürük olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Çocuğun aşıları eksiktir.” ve “Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” birlikte okunduğunda Bordetella pertussis seçeneği öne çıkar; “Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis pozitif saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Eksik aşıli çocukta kataral dönem sonrası gelişen paroksizmal boğulur tarzda öksürük, öksürük sonrası kusma ve lenfositoz Bordetella pertussis enfeksiyonunu düşündürür. PCR pozitifliği etkeni doğrular. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuğun aşıları eksiktir.”, “Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis pozitif saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Bordetella pertussis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuğun aşıları eksiktir.

Kanıt 2: Paroksizmal boğulur tarzda öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.

Kanıt 3: Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Boğmacada paroksizmal öksürük, inspiratuvar whoop ve lenfositoz klasik ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 236: v186-new-236-derin-yumusak-doku-kitlesi

Başlık: Derin yumuşak doku kitlesi

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: İyi diferansiye liposarkomda atipik stromal hücre ve lipoblast varlığını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, uylukta yavaş büyüyen ağrısız kitle nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık bir yıldır sağ uyluk derininde giderek büyüyen kitle fark ettiğini, travma öyküsü olmadığını belirtmektedir. Kilo kaybı veya ateş tariflememektedir.

Demografi: 61 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ uyluk proksimalinde derin yerleşimli, hareketi sınırlı, ağrısız büyük kitle palpe edilir.
- Ciltte ülserasyon yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Manyetik rezonans görüntüleme

Etiket: Manyetik rezonans görüntüleme | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Derin yumuşak dokuda yağ içerikli, kalın septalı büyük kitle izlendi. | Klinik anlam: Liposarkom açısından şüpheli görünüm. | Sonuç yorumu: Liposarkom açısından şüpheli görünüm. | Sonuç başlığı: Manyetik rezonans görüntüleme | Sonuç özeti: Derin yumuşak dokuda yağ içerikli, kalın septalı büyük kitle izlendi. | Yorum: Liposarkom açısından şüpheli görünüm. | Satırlar: Manyetik rezonans görüntüleme / 12 cm // Liposarkom açısından şüpheli görünüm.

Tetkik 2: Biyopsi histopatolojisi

Etiket: Biyopsi histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Atipik stromal hücreler ve vakuollü sitoplazmalı lipoblastlar izlendi. | Klinik anlam: Adipositik malign tümörü destekler. | Sonuç yorumu: Adipositik malign tümörü destekler. | Sonuç başlığı: Biyopsi histopatolojisi | Sonuç özeti: Atipik stromal hücreler ve vakuollü sitoplazmalı lipoblastlar izlendi. | Yorum: Adipositik malign tümörü destekler. | Satırlar: Biyopsi histopatolojisi / Atipik stromal hücreler ve vakuollü sitoplazmalı lipoblastlar izlendi. // Adipositik malign tümörü destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-123 | Başlık: Manyetik rezonans görüntüleme | Modalite: mri | Bulgu: Derin yumuşak dokuda yağ içerikli, kalın septalı büyük kitle izlendi. | Klinik anlam: Liposarkom açısından şüpheli görünüm. | URL: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/123_liposarkom_yumusak_doku_mr.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/123_liposarkom_yumusak_doku_mr.webp | Alt text: Manyetik rezonans görüntüleme - Derin yumuşak dokuda yağ içerikli, kalın septalı büyük kitle izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-124 | Başlık: Biyopsi histopatolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Atipik stromal hücreler ve vakuollü sitoplazmalı lipoblastlar izlendi. | Klinik anlam: Adipositik malign tümörü destekler. | URL: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/124_liposarkom_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/124_liposarkom_histopatoloji.webp | Alt text: Biyopsi histopatolojisi - Atipik stromal hücreler ve vakuollü sitoplazmalı lipoblastlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Lipom
- B) Nodüler fasiit
- C) İyi diferansiye liposarkom
- D) Rabdomiyom
- E) Ganglion kisti

Doğru Cevap: İyi diferansiye liposarkom

A) Lipom: Lipom benign, genellikle atipisiz ve daha yüzeysel yağ dokusu tümörüdür; lipoblast ve atipik stromal hücre beklenmez. Bu olguda “Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.” ve “Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından iyi diferansiye liposarkom seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nodüler fasiit: Nodüler fasiit hızlı büyüyen reaktif fibroblastik lezyondur; yağ içerikli büyük derin kitle ve lipoblast paternine uymaz. Bu olguda “Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.” ve “Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından iyi diferansiye liposarkom seçeneğini daha güçlü kılar.

C) İyi diferansiye liposarkom: İyi diferansiye liposarkom derin büyük yağ içerikli kitle, kalın septa, atipik stromal hücreler ve lipoblastlarla en uyumludur. Vakadaki “Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.” ve “Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Rabdomiyom: Vakadaki Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur ve Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir. Bu olguda “Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.” ve “Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından iyi diferansiye liposarkom seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ganglion kisti: Ganglion kisti eklem veya tendon kılıfıyla ilişkili kistik lezyondur; derin yağ içerikli atipik tümör paternine uymaz. Bu olguda “Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.” ve “Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından iyi diferansiye liposarkom seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Derin yumuşak doku kitlesi olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.” ve “Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.” birlikte okunduğunda iyi diferansiye liposarkom seçeneği öne çıkar; “Biyopside atipik stromal hücreler ve lipoblastlar saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı hastada derin yerleşimli, büyük, yavaş büyüyen yağ içerikli kitle ve biyopside atipik stromal hücrelerle lipoblast görülmesi iyi diferansiye liposarkomu düşündürür. Basit lipom genellikle yüzeysel, küçük ve atipsizdir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.”, “Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.” ve “Biyopside atipik stromal hücreler ve lipoblastlar saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle iyi diferansiye liposarkom en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kitle derin yumuşak dokuda ve büyük boyutludur.

Kanıt 2: Görüntülemde kalın septalı yağ içerikli yapı izlenmiştir.

Kanıt 3: Biyopside atipik stromal hücreler ve lipoblastlar saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanitten ayrılır.

Exam Pearl: Derin ve büyük yağ dokusu tümöründe atipi ve lipoblast varlığı liposarkom lehinedir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 237: v186-new-237-gogus-agrisinda-dil-alti-ilac

Başlık: Göğüs ağrısında dil altı ilaç

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Nitratların venodilatasyon ve preload azaltıcı etkisini klinik kullanım ile ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, eforla gelen göğüs ağrısı için verilen dil altı ilacın etkisini öğrenmek istemektedir. Koroner arter hastalığı tanısı vardır. Merdiven çıkarken göğüste baskı hissi geliştiğini ve dinlenmekle geçtiğini belirtmektedir. Dil altı nitrogliserin kullanınca ağrısının kısa sürede azaldığını ifade eder.

Demografi: 56 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 122/76 mmHg | Nabız: 78/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,64

Fizik Muayene

- Muayene sırasında göğüs ağrısı yoktur.
- Kardiyopulmoner muayene doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Nitrogliserinin angina semptomlarını azaltmasındaki temel hemodinamik etki aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Afterloadu artırarak miyokard oksijen tüketimini yükseltmesi
- B) Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi
- C) Beta-1 reseptörleri uyarak kalp hızını artırması
- D) Trombosit P2Y₁₂ reseptörlerini irreversibl inhibe etmesi
- E) Renal sodyum geri emilimini artırması

Doğru Cevap: Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi

A) Afterloadu artırarak miyokard oksijen tüketimini yükseltmesi: Vakadaki Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır ve Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır. Bu olguda “Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.” ve “Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi: Venodilatasyonla preloadu azaltmak nitrogliserinin angina semptomlarını azaltan temel hemodinamik etkisidir. Vakadaki “Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.” ve “Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Beta-1 reseptörleri uyarak kalp hızını artırması: Beta-1 reseptör uyarımı kalp hızını ve oksijen ihtiyacını artırır; nitratların temel etkisi değildir. Bu olguda “Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.” ve “Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Trombosit P2Y₁₂ reseptörlerini irreversibl inhibe etmesi: Vakadaki Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır ve Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır. Bu olguda “Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.” ve “Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Renal sodyum geri emilimini artırması: Renal sodyum geri emilimini artırmak preloadu azaltmaz ve nitrogliserinin angina etkisini açıklamaz. Bu olguda “Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.” ve “Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Göğüs ağrısında dil altı ilaç olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.” ve “Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.” birlikte okunduğunda Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi seçeneği öne çıkar; “Soru ilacın hemodinamik etkisini sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nitratlar nitrik oksit üzerinden düz kas gevşemesi yapar ve düşük dozlarda venodilatasyon baskındır. Venöz dönüş ve preload azalınca ventrikül duvar gerilimi ve miyokard oksijen ihtiyacı düşer; bu da angina semptomlarını azaltır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.”, “Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.” ve “Soru ilacın hemodinamik etkisini sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Venodilatasyonla preloadu azaltarak miyokard oksijen ihtiyacını düşürmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada eforla gelen ve dinlenmekle azalan angina paterni vardır.

Kanıt 2: Dil altı nitrogliserin sonrası ağrı kısa sürede azalmaktadır.

Kanıt 3: Soru ilacın hemodinamik etkisini sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından

doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Nitratlar özellikle venodilatasyon yaparak preloadu ve miyokard oksijen ihtiyacını azaltır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 238: v186-new-238-bakla-sonrasi-sarilik-ve-koyu-idrar

Başlık: Bakla sonrası sarılık ve koyu idrar

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde oksidatif stresle hemoliz mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, halsizlik, sarılık ve koyu renkli idrar nedeniyle başvuruyor. İki gün önce bakla yediğini, ardından halsizlik ve gözlerde sararma geliştiğini belirtmektedir. Daha önce bazı ilaçlardan sonra benzer yakınmalar yaşadığını ifade eder.

Demografi: 19 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,96 (sınırdı yüksek)

Fizik Muayene

- Skleralar ikteriktir.
- Hafif taşikardi vardır.
- Dalak belirgin büyümemiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Akut hemolizi destekler. | Sonuç yorumu: Akut hemolizi destekler. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Akut hemolizi destekler. | Satırlar: Hemoglobin / 8.9 g/dL / 13.5-17.5 g/dL / Akut hemolizi destekler.

Tetkik 2: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Oksidatif eritrosit hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Oksidatif eritrosit hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlendi. | Yorum: Oksidatif eritrosit hasarını destekler. | Satırlar: Periferik yayma / Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlendi. // Oksidatif eritrosit hasarını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-125 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Oksidatif eritrosit hasarını destekler. | URL: https://iukbtlkzicxtdsds.public.blob.vercel-storage.com/125_g6pd_eksikligi_heinz_bite_cells_yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzicxtdsds.public.blob.vercel-storage.com/125_g6pd_eksikligi_heinz_bite_cells_yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel biyokimyasal sorun aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Heme sentezinde ferroşelataz aktivitesinin artması
B) NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi
C) Globin zincir sentezinin artması
D) Vitamin B12 emiliminin artması
E) Pürin kurtarma yolunun aşırı çalışması

Doğru Cevap: NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi

A) Heme sentezinde ferroşelataz aktivitesinin artması: Ferroşelataz heme sentezinde görev alır; bu Vakadaki oksidatif hemolizin temel nedeni değildir. Bu olguda “Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.” ve “Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.” ipuçları klinik karar açısından NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi: NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi G6PD eksikliğinde oksidatif hemolizi açıklar. Vakadaki “Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.” ve “Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Globin zincir sentezinin artması: Globin zincir sentezinin artması talasemi mekanizması değildir ve bu yayma bulgularını açıklamaz. Bu olguda “Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.” ve “Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.” ipuçları klinik karar açısından NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Vitamin B12 emiliminin artması: Vakadaki Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır ve Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir. Bu olguda “Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.” ve “Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.” ipuçları klinik karar açısından NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Pürin kurtarma yolunun aşırı çalışması: Pürin kurtarma yolunun aşırı çalışması Lesch-Nyhan mantığıyla ilişkili değildir ve oksidatif eritrosit hasarını açıklamaz. Bu olguda “Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.” ve “Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.” ipuçları klinik karar açısından NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bakla sonrası sarılık ve koyu idrar olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.” ve “Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.” birlikte okunduğunda NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi seçeneği öne çıkar; “Periferik yaymada Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde pentoz fosfat yolundan NADPH üretimi azalır. NADPH yetersizliği indirgenmiş glutatyonun yenilenmesini bozar; eritrositler oksidatif strese duyarlı hale gelir ve bakla veya ilaçlar sonrası hemoliz gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.”, “Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.” ve “Periferik yaymada Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle NADPH üretiminin azalması ve indirgenmiş glutatyonun yenilenememesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hemoliz atağı bakla tüketiminden sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Sarılık ve koyu idrar akut hemolizi düşündürmektedir.

Kanıt 3: Periferik yaymada Heinz cisimcikleri ve ısırk hücreleri izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

BRANŞ: general-surgery

VAKA 239: v186-new-239-diskilama-sirasinda-siddetli-agri

Başlık: Dışkılama sırasında şiddetli ağrı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Anal fissürde ağrı-kanama ilişkisini hemoroidden ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, dışkılama sırasında cam kesiği tarzında ağrı ve az miktarda parlak kırmızı kanama nedeniyle başvuruyor. Kabızlık sonrası yakınmalarının başladığını, ağrının dışkılama sırasında çok şiddetlendiğini ve sonrasında bir süre devam ettiğini belirtmektedir. Kanama tuvalet kâğıdına bulaşacak miktardadır.

Demografi: 35 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Perianal muayenede posterior orta hatta lineer mukozal yırtık izlenir.
- Belirgin prolabe hemoroidal paket yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündürülen belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İç hemoroid
B) Anal fissür
C) Rektum kanseri
D) Perianal fistül
E) Pilonidal sinüs

Doğru Cevap: Anal fissür

A) İç hemoroid: İç hemoroid genellikle ağrısız parlak kırmızı kanama yapar; cam kesiği tarzı ağrı ve lineer yırtık anal fissür lehinedir. Bu olguda “Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.” ve “Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.
B) Anal fissür: Anal fissür kabızlık sonrası dışkılama sırasında şiddetli ağrı, az kanama ve posterior orta hat yırtığıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.” ve “Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
C) Rektum kanseri: Rektum kanseri dışkılama alışkanlığında değişiklik, kilo kaybı veya kitle bulgularıyla düşünülür; akut lineer yırtık paterniyle uyumlu değildir. Bu olguda “Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.” ve “Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Perianal fistül: Perianal fistül kronik akıntı ve dış ağızla seyredir; dışkılama sırasında cam kesiği ağrısını açıklamaz. Bu olguda “Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.” ve “Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Pilonidal sinüs: Pilonidal sinüs sakrokoksigeal bölgede akıntılı sinüs veya apseye ilişkilidir; anal kanal yırtığı değildir. Bu olguda “Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.” ve “Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Anal fissür seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Dışkılama sırasında şiddetli ağrı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.” ve “Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Anal fissür seçeneği öne çıkar; “Muayenede posterior orta hatta lineer yırtık izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Dışkılama sırasında cam kesiği tarzında şiddetli ağrı, az miktarda parlak kanama, kabızlık öyküsü ve posterior orta hatta lineer yırtık anal fissür için tipiktir. İç hemoroid kanaması genellikle ağrısızdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.”, “Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.” ve “Muayenede posterior orta hatta lineer yırtık izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Anal fissür en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ağrı dışkılama sırasında cam kesiği tarzında tariflenmektedir.

Kanıt 2: Kabızlık sonrası az miktarda parlak kırmızı kanama gelişmiştir.

Kanıt 3: Muayenede posterior orta hatta lineer yırtık izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Ağrılı dışkılama ve posterior orta hat yırtığı anal fissürü düşündürür; iç hemoroid çoğu kez ağrısız kanar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 240: v186-new-240-renal-perfüzyon-azalmasına-yanıt

Başlık: Renal perfüzyon azalmasına yanıt

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminde efferent arteriyol tonusunun GFR üzerindeki etkisini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde renal perfüzyon basıncı azaldığında anjiyotensin II aracılı glomerüler filtrasyon yanıtı tartışılıyor. Bilinen böbrek hastalığı veya antihipertansif ilaç kullanımı yoktur. Değerlendirme deneysel fizyoloji simülasyonu üzerinden yapılmaktadır.

Demografi: 40 yaşında sağlıklı gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/72 mmHg | Nabız: 72/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,61

Fizik Muayene

- Dinlenim muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fizyolojik simülasyon

Etiket: Fizyolojik simülasyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Renal perfüzyon basıncında azalma ve anjiyotensin II düzeyinde artış modellendi. | Klinik anlam: Glomerüler hemodinamik kompanzasyonu değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç yorumu: Glomerüler hemodinamik kompanzasyonu değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç başlığı: Fizyolojik simülasyon | Sonuç özeti: Renal perfüzyon basıncında azalma ve anjiyotensin II düzeyinde artış modellendi. | Yorum: Glomerüler hemodinamik kompanzasyonu değerlendirmek için kullanılmıştır. | Satırlar: Fizyolojik simülasyon / Renal perfüzyon basıncında azalma ve anjiyotensin II düzeyinde artış modellendi. // Glomerüler hemodinamik kompanzasyonu değerlendirmek için kullanılmıştır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Orta düzey anjiyotensin II artışının glomerüler filtrasyon hızını korumaya yardım eden temel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Afferent arteriyolu tamamen kapatması
B) Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi
C) Bowman kapsülü hidrostatik basıncını artırması
D) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunu başlatması
E) Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimini tamamen durdurması

Doğru Cevap: Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi

A) Afferent arteriyolu tamamen kapatması: Vakadaki Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır ve Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir. Bu olguda “Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.” ve “Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi: Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon glomerüler kapiller basıncı destekleyerek düşük perfüzyonda GFR'nin korunmasına yardım eder. Vakadaki “Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.” ve “Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Bowman kapsülü hidrostatik basıncını artırması: Bowman kapsülü hidrostatik basıncının artması filtrasyonu azaltır; GFR'yi koruyan mekanizma değildir. Bu olguda “Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.” ve “Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunu başlatması: Proksimal tübülde glukoz sekresyonu fizyolojik bir RAAS yanıtı değildir; glukoz esas olarak geri emilir. Bu olguda “Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.” ve “Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Toplayıcı kanalda sodyum geri emilimini tamamen durdurması: Toplayıcı kanalda sodyum geri emiliminin durması aldosteron etkisiyle uyumlu değildir ve GFR korunmasını açıklamaz. Bu olguda “Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.” ve “Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Renal perfüzyon azalmasına yanıt olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.” ve “Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.” birlikte okunduğunda Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi seçeneği öne çıkar; “Soru glomerüler filtrasyon hızının hemodinamik korunmasını sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Renal perfüzyon azaldığında renin-anjiyotensin sistemi aktive olur. Orta düzey anjiyotensin II özellikle efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller hidrostatik basıncı destekler ve glomerüler filtrasyon hızının korunmasına katkı sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.”, “Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.” ve “Soru glomerüler filtrasyon hızının hemodinamik korunmasını sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Efferent arteriyolde vazokonstriksiyon yaparak glomerüler kapiller basıncı desteklemesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Simülasyonda renal perfüzyon basıncı azaltılmıştır.

Kanıt 2: Anjiyotensin II düzeyinde artış modellenmiştir.

Kanıt 3: Soru glomerüler filtrasyon hızının hemodinamik korunmasını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Anjiyotensin II efferent arteriyolu daraltarak düşük renal perfüzyonda GFR'nin korunmasına yardım eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 241: v187-new-241-gece-artan-el-uyusmasi

Başlık: Gece artan el uyuşması

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulguyla ilişkilendirme.

Learning Target: Karpal tünel sendromunda nervus medianus basısını motor ve duyu bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ elde gece artan uyuşma ve kavrama güçlüğü nedeniyle başvuruyor. Yakınmalarının özellikle ilk üç parmakta belirgin olduğunu, gece uykudan uyandırdığını ve elini sallayınca kısmen azaldığını belirtmektedir. Uzun süre bilgisayar kullandığı öğreniliyor.

Demografi: 46 yaşında kadın hasta | Setting: nöroloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ elde tenar bölgede hafif atrofi izlenir.
- Başparmak opozisyonu zayıftır.
- İlk üç parmak ve dördüncü parmağın radial yarısında duyu azalması vardır.
- Tinel testi el bileğinde pozitifdir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada basıya uğrayan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus medianus
B) Nervus ulnaris
C) Nervus radialis
D) Nervus musculocutaneus
E) Nervus axillaris

Doğru Cevap: Nervus medianus

A) Nervus medianus: Nervus medianus karpal tünelinden geçtiği için tenar zayıflık ve lateral üç buçuk parmak duyu kaybını açıklar. Vakadaki "Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir." ve "Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Nervus ulnaris: Nervus ulnaris Guyon kanalı veya dirsek düzeyinde etkilenir ve ulnar bir buçuk parmak duysusu ile interosseöz kas bulguları beklenir. Bu olguda "Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir." ve "Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus radialis: Nervus radialis el bileği ekstansiyonu ve el sırtı duysusuyla ilişkilidir; tenar opozisyon kaybını açıklamaz. Bu olguda "Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir." ve "Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nervus musculocutaneus: Nervus musculocutaneus dirsek fleksiyonu ve lateral ön kol duysusunu etkiler; karpal tünel bulgularını açıklamaz. Bu olguda "Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir." ve "Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus axillaris: Nervus axillaris deltoid kas ve lateral omuz duysusuyla ilişkilidir; el parmak duyu dağılımını açıklamaz. Bu olguda "Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir." ve "Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus medianus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gece artan el uyuşması olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. "Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir." ve "Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır." birlikte okunduğunda Nervus medianus seçeneği öne çıkar; "Tinel testi el bileğinde pozitifdir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Karpal tünel içinde fleksör tendonlarla birlikte nervus medianus seyreder. İlk üç parmakta parestezi, tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı median sinir basısını destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir.", "Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır." ve "Tinel testi el bileğinde pozitifdir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus medianus en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Uyuşma ilk üç parmakta ve gece belirginleşmektedir.

Kanıt 2: Tenar atrofi ve başparmak opozisyon zayıflığı vardır.

Kanıt 3: Tinel testi el bileğinde pozitifdir.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguya uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Karpal tünel sendromunda nervus medianus etkilenir; tenar motor kayıp ve lateral üç buçuk parmak duysusu tipiktir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 242: v187-new-242-tiroid-ameliyati-sonrasi-ses-kisikligi

Başlık: Tiroid ameliyatı sonrası ses kısıklığı

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulguyla ilişkilendirme.

Learning Target: Tiroid cerrahisi sonrası nervus laryngeus recurrens hasarını ses kısıklığıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tiroid ameliyatı sonrası başlayan ses kısıklığı ve çabuk yorulan ses nedeniyle başvuruyor. Multinodüler guatr nedeniyle total tiroidektomi geçirdiği öğreniliyor. Ameliyat sonrası yutma sırasında belirgin aspirasyon tariflemiyor ancak konuşurken sesinin kısık ve zayıf çıktığını belirtmektedir.

Demografi: 52 yaşında kadın hasta | Setting: endokrin cerrahi kontrolünde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Ses kalitesi boğuk ve kısıktır.
- Dil hareketleri normaldir.
- Omuz elevasyonu korunmuştur.
- Laringoskopide sağ vokal kord hareketinin azaldığı bildirilmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki bulguları en iyi açıklayan sinir hasarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus hypoglossus
B) Nervus laryngeus recurrens
C) Nervus accessorius
D) Nervus glossopharyngeus
E) Nervus facialis

Doğru Cevap: Nervus laryngeus recurrens

A) Nervus hypoglossus: Nervus hypoglossus dil kaslarını innerve eder ve hasarında dil deviasyonu beklenir; vokal kord paralizisini açıklamaz. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Nervus laryngeus recurrens: Nervus laryngeus recurrens tiroid cerrahisinde risk altındadır ve vokal kord hareket kaybı ile ses kısıklığını açıklar. Vakadaki “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Nervus accessorius: Nervus accessorius sternocleidomastoideus ve trapezius kaslarını innerve eder; omuz elevasyonu bu hastada korunmuştur. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nervus glossopharyngeus: Nervus glossopharyngeus yutma ve farengeal duyu ile ilişkilidir; vokal kord hareketinin ana motor siniri değildir. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus facialis: Nervus facialis mimik kaslarını innerve eder; tiroid cerrahisi sonrası vokal kord hareket kaybını açıklamaz. Bu olguda “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Nervus laryngeus recurrens seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tiroid ameliyatı sonrası ses kısıklığı olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.” ve “Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.” birlikte okunduğunda Nervus laryngeus recurrens seçeneği öne çıkar; “Dil hareketi ve omuz elevasyonu korunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nervus laryngeus recurrens tiroid bezi posteromedial komşuluğunda seyreder ve larenks intrinsik kaslarının çoğunu innerve eder. Cerrahi sonrası vokal kord hareket azalması ve ses kısıklığı bu sinir hasarıyla uyumludur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.”, “Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.” ve “Dil hareketi ve omuz elevasyonu korunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus laryngeus recurrens en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ses kısıklığı total tiroidektomi sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Laringoskopide sağ vokal kord hareketi azalmıştır.

Kanıt 3: Dil hareketi ve omuz elevasyonu korunmuştur.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguya uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Tiroid cerrahisi sonrası ses kısıklığında nervus laryngeus recurrens hasarı düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 243: v187-new-243-yenidoganda-lumbosakral-kese

Başlık: Yenidoğanda lumbosakral kese

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Nöral tüp kapanma kusurunda folat eksikliğini spina bifida bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumda lumbosakral bölgede kese benzeri çıkıntı fark edilmesi nedeniyle değerlendirmeye alınıyor. Annenin gebelik öncesi folik asit kullanmadığı ve gebeliğin erken döneminde düzenli takip yaptırmadığı öğreniliyor. Doğum miadında gerçekleşmiştir.

Demografi: 1 günlük kız yenidoğan | Setting: yenidoğan cerrahisi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Lumbosakral bölgede üzeri ince zarla kaplı kese izlenir.
- Alt ekstremitelerde hareket azalması ve anal sfinkter tonusunda zayıflık vardır.
- Baş çevresi normal sınırlardadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Spinal manyetik rezonans görüntüleme

Etiket: Spinal manyetik rezonans görüntüleme | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Lumbosakral bölgede meninges ve spinal kord dokusunu içeren defekt izlendi. | Klinik anlam: Meningomyelosele ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Meningomyelosele ile uyumludur. | Sonuç başlığı: Spinal manyetik rezonans görüntüleme | Sonuç özeti: Lumbosakral bölgede meninges ve spinal kord dokusunu içeren defekt izlendi. | Yorum: Meningomyelosele ile uyumludur. | Satırlar: Spinal manyetik rezonans görüntüleme / Lumbosakral bölgede meninges ve spinal kord dokusunu içeren defekt izlendi. // Meningomyelosele ile uyumludur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-126 | Başlık: Spinal manyetik rezonans görüntüleme | Modalite: mri | Bulgu: Lumbosakral bölgede meninges ve spinal kord dokusunu içeren defekt izlendi. | Klinik anlam: Meningomiyelosele ile uyumludur. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/126_meningomiyelosele_spinal_mr.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/126_meningomiyelosele_spinal_mr.webp | Alt text: Spinal manyetik rezonans görüntüleme - Lumbosakral bölgede meninges ve spinal kord dokusunu içeren defekt izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu anomalinin temel embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kaudal nöropor kapanma kusuru
- B) Rostral nöropor erken kapanması
- C) Omfalomezenterik kanal persiste kalması
- D) Üçüncü faringeal poş gelişim kusuru
- E) Ürakuşun açık kalması

Doğru Cevap: Kaudal nöropor kapanma kusuru

A) Kaudal nöropor kapanma kusuru: Kaudal nöropor kapanma kusuru lumbosakral meningomiyelosele ve alt ekstremitte nörolojik bulgularını açıklar. Vakadaki “Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.” ve “Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöropor kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Rostral nöropor erken kapanması: Rostral nöropor kapanma kusuru anensefali gibi kranial defektlerle ilişkilidir; lumbosakral kese paternini açıklamaz. Bu olguda “Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.” ve “Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöropor kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Omfalomezenterik kanal persiste kalması: Omfalomezenterik kanal persiste kalması Meckel divertikülüne yol açar; spinal defekt oluşturmaz. Bu olguda “Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.” ve “Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöropor kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Üçüncü faringeal poş gelişim kusuru: Üçüncü faringeal poş gelişim kusuru timus ve paratiroid hipoplazisiyle ilişkilidir; lumbosakral nöral tüp defekti değildir. Bu olguda “Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.” ve “Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöropor kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ürakuşun açık kalması: Ürakuşun açık kalması umbilikustan idrar gelmesine yol açabilir; meningomiyelosele mekanizması değildir. Bu olguda “Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.” ve “Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Kaudal nöropor kapanma kusuru seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda lumbosakral kese olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.” ve “Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.” birlikte okunduğunda Kaudal nöropor kapanma kusuru seçeneği öne çıkar; “Gebelik öncesi folik asit kullanımı yoktur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Meningomiyelosele, nöral tüpün kaudal kısmının kapanma kusuruna bağlıdır. Folat eksikliği nöral tüp defekti riskini artırır; spinal kord ve meninges defektten dışarı çıkabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.”, “Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.” ve “Gebelik öncesi folik asit kullanımı yoktur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kaudal nöropor kapanma kusuru en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Lumbosakral bölgede kese benzeri defekt vardır.

Kanıt 2: Manyetik rezonans görüntülemesinde meninges ve spinal kord dokusu defekte katılmıştır.

Kanıt 3: Gebelik öncesi folik asit kullanımı yoktur.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Folat eksikliği nöral tüp defekti riskini artırır; meningomiyelosele kaudal nöropor kapanma kusurudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 244: v187-new-244-hormonal-uretim-bolgesinin-belirlenmesi

Başlık: Hormonal üretim bölgesinin belirlenmesi

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Histolojik yapıyı klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Adrenal korteks zona glomerulozasını aldosteron üretimiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hastada hipertansiyon ve hipokalemiye eşlik eden aldosteron fazlalığı saptanıyor. Yıllardır kontrolü zor hipertansiyonu olduğu, son aylarda kas güçsüzlüğü yaşadığı öğreniliyor. Antihipertansif tedaviye rağmen kan basıncı yüksek seyretmektedir.

Demografi: 43 yaşında kadın hasta | Setting: endokrinoloji polikliniğinde değerlendirilmiş adrenal nodül nedeniyle inceleniyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 158/94 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,53

Fizik Muayene

- Hafif kas güçsüzlüğü vardır.
- Cushingoid görünüm izlenmez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma aldosteron/renin oranı

Etiket: Plazma aldosteron/renin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Primer aldosteron fazlalığını destekler. | Sonuç yorumu: Primer aldosteron fazlalığını destekler. | Sonuç başlığı: Plazma aldosteron/renin oranı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Primer aldosteron fazlalığını destekler. | Satırlar: Plazma aldosteron/renin oranı / Yüksek saptandı. // Primer aldosteron fazlalığını destekler.

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Mineralokortikoid etkisini destekler. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid etkisini destekler. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Mineralokortikoid etkisini destekler. | Satırlar: Serum potasyum / Düşük saptandı. / 3.0 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Aldosteronun fizyolojik olarak üretildiği adrenal korteks bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Zona glomerulosa
B) Zona fasciculata
C) Zona reticularis
D) Adrenal medulla
E) Kapsül fibroblastları

Doğru Cevap: Zona glomerulosa

A) Zona glomerulosa: Zona glomerulosa aldosteron üretin mineralokortikoid bölgesidir ve bu hastadaki hormonal fazlalıkla doğrudan ilişkilidir. Vakadaki “Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.” ve “Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Zona fasciculata: Vakadaki Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır ve Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler. Bu olguda “Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.” ve “Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.” ipuçları klinik karar açısından Zona glomerulosa seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Zona reticularis: Vakadaki Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır ve Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler. Bu olguda “Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.” ve “Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.” ipuçları klinik karar açısından Zona glomerulosa seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Adrenal medulla: Vakadaki Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır ve Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler. Bu olguda “Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.” ve “Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.” ipuçları klinik karar açısından Zona glomerulosa seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Kapsül fibroblastları: Vakadaki Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır ve Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler. Bu olguda “Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.” ve “Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.” ipuçları klinik karar açısından Zona glomerulosa seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hormonal üretim bölgesinin belirlenmesi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.” ve “Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.” birlikte okunduğunda Zona glomerulosa seçeneği öne çıkar; “Soru adrenal korteksin hormon üretim bölgesini sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Adrenal kortekte zona glomerulosa mineralokortikoid sentezinden sorumludur ve aldosteron üretir. Zona fasciculata glukokortikoid, zona reticularis ise adrenal androjen üretimiyle ilişkilidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.”, “Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.” ve “Soru adrenal korteksin hormon üretim bölgesini sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Zona glomerulosa en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada aldosteron fazlalığı saptanmıştır.

Kanıt 2: Hipertansiyon ve hipokalemi mineralokortikoid etkisini destekler.

Kanıt 3: Soru adrenal korteksin hormon üretim bölgesini sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Adrenal korteks dıştan içe zona glomerulosa, fasciculata ve reticularis olarak düzenlenir; aldosteron glomerulosada üretilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 245: v187-new-245-hipertansiyon-ve-hipokalemi

Başlık: Hipertansiyon ve hipokalemi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Primer hiperaldosteronizmde böbrek potasyum ve hidrojen iyonu atılımının yönünü açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, dirençli hipertansiyon ve kas güçsüzlüğü nedeniyle başvuruyor. Üç farklı antihipertansif kullanmasına rağmen kan basıncının yüksek seyrettiği, son dönemde kas krampları ve halsizlik yaşadığı öğreniliyor.

Demografi: 49 yaşında erkek hasta | Setting: endokrinoloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 164/98 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,51

Fizik Muayene

- Hafif proksimal kas güçsüzlüğü vardır.
- Ödem belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Aldosteron fazlalığına bağlı renal kaybı destekler. | Sonuç yorumu: Aldosteron fazlalığına bağlı renal kaybı destekler. | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Aldosteron fazlalığına bağlı renal kaybı destekler. | Satırlar: Serum potasyum / Düşük saptandı. / 2.9 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L

Tetkik 2: Arter kan gazı

Etiket: Arter kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik alkaloz saptandı. | Klinik anlam: Hidrojen iyonu kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Hidrojen iyonu kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Arter kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik alkaloz saptandı. | Yorum: Hidrojen iyonu kaybını destekler. | Satırlar: Arter kan gazı / Metabolik alkaloz saptandı. / pH 7.48, HCO₃ 31 mmol/L / pH 7.35-7.45, HCO₃ 22-26 mmol/L

Tetkik 3: Plazma renin aktivitesi

Etiket: Plazma renin aktivitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Baskılanmış saptandı. | Klinik anlam: Primer aldosteron fazlalığı lehinedir. | Sonuç yorumu: Primer aldosteron fazlalığı lehinedir. | Sonuç başlığı: Plazma renin aktivitesi | Sonuç özeti: Baskılanmış saptandı. | Yorum: Primer aldosteron fazlalığı lehinedir. | Satırlar: Plazma renin aktivitesi / Baskılanmış saptandı. / / Primer aldosteron fazlalığı lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Aldosteron fazlalığının bu hastadaki hipokalemi ve alkalozu oluşturma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması
B) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunu artırması
C) Toplayıcı kanalda su geçirgenliğini tamamen azaltması
D) Glomerüler filtrasyonu tamamen durdurması

E) Henle kulpunda kalsiyum geri emilimini tamamen engellemesi

Doğru Cevap: Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması

A) Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması: Distal nefronda sodyum geri emilimini artırıp potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması hiperaldosteronizm bulgularını açıklar. Vakadaki “Hastada dirençli hipertansiyon vardır.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunu artırması: Proksimal tübülde glukoz sekresyonu aldosteronun temel etkisi değildir; glukoz normalde geri emilir. Bu olguda “Hastada dirençli hipertansiyon vardır.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Toplayıcı kanalda su geçirgenliğini tamamen azaltması: Toplayıcı kanalda su geçirgenliğini antidiüretik hormon düzenler; aldosteronun hipokalemi mekanizması bu değildir. Bu olguda “Hastada dirençli hipertansiyon vardır.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Glomerüler filtrasyonu tamamen durdurması: Glomerüler filtrasyonun tamamen durması bu kronik hipertansiyon-hipokalemi paternini açıklamaz. Bu olguda “Hastada dirençli hipertansiyon vardır.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Henle kulpunda kalsiyum geri emilimini tamamen engellemesi: Henle kulpunda kalsiyum geri emiliminin engellenmesi aldosteron fazlalığının temel etkisi değildir. Bu olguda “Hastada dirençli hipertansiyon vardır.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hipertansiyon ve hipokalemi olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hastada dirençli hipertansiyon vardır.” ve “Serum potasyumu düşüktür.” birlikte okunduğunda Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması seçeneği öne çıkar; “Metabolik alkaloz ve baskılanmış renin saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Aldosteron distal nefronda epitel sodyum kanalı ve Na/K ATPaz aktivitesini artırarak sodyum geri emilimini artırır. Elektronegatif lümen potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırır; hipokalemi ve metabolik alkaloz gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada dirençli hipertansiyon vardır.”, “Serum potasyumu düşüktür.” ve “Metabolik alkaloz ve baskılanmış renin saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Distal nefronda sodyum geri emilimini artırırken potasyum ve hidrojen iyonu sekresyonunu artırması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada dirençli hipertansiyon vardır.

Kanıt 2: Serum potasyumu düşüktür.

Kanıt 3: Metabolik alkaloz ve baskılanmış renin saptanmıştır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Aldosteron fazlalığı hipertansiyon, hipokalemi ve metabolik alkaloz yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 246: v187-new-246-egzersizde-oksijen-dusuklugu

Başlık: Egzersizde oksijen düşüklüğü

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Difüzyon kapasitesi azalmasında egzersizle belirginleşen hipoksemiye açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, özellikle eforla belirginleşen nefes darlığı nedeniyle başvuruyor. Uzun yıllar interstisyel akciğer hastalığı nedeniyle takip edildiği öğreniliyor. Dinlenimde yakınmaları hafifken yürüyüş sırasında oksijen satürasyonunun belirgin düştüğünü belirtmektedir.

Demografi: 58 yaşında erkek hasta | Setting: göğüs hastalıkları polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 20/dk | SpO₂: %94% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Alt zonlarda ince inspiratuvar raller duyulur.
- Egzersizle satürasyon %84'e düşmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Karbon monoksit difüzyon kapasitesi

Etiket: Karbon monoksit difüzyon kapasitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Alveol-kapiller difüzyon bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Alveol-kapiller difüzyon bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Karbon monoksit difüzyon kapasitesi | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Alveol-kapiller difüzyon bozukluğunu destekler. | Satırlar: Karbon monoksit difüzyon kapasitesi / Düşük saptandı. / 45 % beklenen / >80% beklenen

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Egzersizde hipokseminin belirginleşmesini en iyi açıklayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi
- B) Hemoglobinin oksijeni geri dönüşümsüz bağlaması
- C) Alveoler ventilasyonun egzersizde tamamen durması
- D) Karbondioksitin oksijenden daha yavaş difüze olması
- E) Pulmoner kapiller kan akımının egzersizde sıfıra düşmesi

Doğru Cevap: Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi

A) Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi: Alveol-kapiller membran kalınlaşması egzersizde kısalan transit sürede oksijen difüzyonunu yetersiz bırakarak hipoksemiye açıklar. Vakadaki “Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.” ve “Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Hemoglobinin oksijeni geri dönüşümsüz bağlaması: Hemoglobinin oksijeni geri dönüşümlü bağlar; geri dönüşümsüz bağlanma fizyolojik gaz değişimiyle uyumlu değildir. Bu olguda “Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.” ve “Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Alveoler ventilasyonun egzersizde tamamen durması: Vakadaki Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır ve Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür. Bu olguda “Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.” ve “Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Karbondioksitin oksijenden daha yavaş difüze olması: Vakadaki Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır ve Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür. Bu olguda “Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.” ve “Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Pulmoner kapiller kan akımının egzersizde sıfıra düşmesi: Pulmoner kapiller kan akımı egzersizde artma eğilimindedir; sıfıra düşmesi fizyolojik değildir. Bu olguda “Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.” ve “Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Egzersizde oksijen düşüklüğü olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.” ve “Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.” birlikte okunduğunda Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi seçeneği öne çıkar; “Oksijen satürasyonu egzersizle belirgin azalmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İnterstisyel akciğer hastalığında alveol-kapiller membran kalınlaşır ve difüzyon kapasitesi azalır. Egzersizde kapiller geçiş süresi kısaldığı için oksijenin dengelenmesi zorlaşır ve hipoksemi belirginleşir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.”, “Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.” ve “Oksijen satürasyonu egzersizle belirgin azalmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Alveol-kapiller membran kalınlaşması nedeniyle oksijen difüzyonunun kapiller geçiş süresine yetişememesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada interstisyel akciğer hastalığı öyküsü vardır.

Kanıt 2: Difüzyon kapasitesi belirgin düşüktür.

Kanıt 3: Oksijen satürasyonu egzersizle belirgin azalmaktadır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Diffüzyon kısıtlılığında hipoksemi egzersizde kapiller transit süresinin kısalmasıyla belirginleşir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 247: v187-new-247-acilikta-hipoglisemi-ve-kas-agrisi

Başlık: Açlıkta hipoglisemi ve kas ağrısı

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Karnitin taşıyıcı sistemi bozukluğunda uzun zincir yağ asidi oksidasyon kusurunu tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, uzun süreli egzersiz sonrası kas ağrısı, halsizlik ve hipoglisemi atakları nedeniyle getiriliyor. Ailesi özellikle aç kaldığında veya uzun süre koştuktan sonra halsizleştiğini ve koyu idrar yaptığını belirtmektedir. Karaciğer hastalığı öyküsü yoktur.

Demografi: 9 yaşında erkek çocuk | Setting: çocuk metabolizma polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Muayenede atak dışında belirgin patoloji yoktur.
- Kas hassasiyeti hafiftir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Açlık kan glukozu

Etiket: Açlık kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Enerji üretim bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Enerji üretim bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Açlık kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Enerji üretim bozukluğunu destekler. | Satırlar: Açlık kan glukozu / Düşük saptandı. / 52 mg/dL / 70-100 mg/dL

Tetkik 2: Serum ketonu

Etiket: Serum ketonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Serum ketonu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler. | Satırlar: Serum ketonu / Düşük saptandı. / / Yağ asidi oksidasyon bozukluğunu destekler.

Tetkik 3: Kreatin kinaz

Etiket: Kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kas etkilenimini destekler. | Sonuç yorumu: Kas etkilenimini destekler. | Sonuç başlığı: Kreatin kinaz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kas etkilenimini destekler. | Satırlar: Kreatin kinaz / Yüksek saptandı. / 2400 U/L / 30-200 U/L

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablo en çok hangi biyokimyasal sürecin bozulmasıyla ilişkilidir?

- A) Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması
- B) Glikojenin lizozom içinde yıkılması
- C) Fenilalaninin tirozine hidroksilasyonu
- D) Galaktozun glukoz-1-fosfata dönüşümü
- E) Homosisteinin metiyonine remetilasyonu

Doğru Cevap: Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması

A) Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması: Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınmasının bozulması açlık-egzersizle tetiklenen hipoketotik hipoglisemi ve kas hasarını açıklar. Vakadaki “Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.” ve “Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Glikojenin lizozom içinde yıkılması: Glikojenin lizozom içinde yıkılması Pompe hastalığıyla ilişkilidir ve kardiyomiopati-hipotoni ön plandadır. Bu olguda “Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.” ve “Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.” ipuçları klinik karar açısından Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Fenilalaninin tirozine hidroksilasyonu: Fenilalaninin tirozine hidroksilasyonu fenilketonüride bozulur; egzersizle rabdomyoliz paternini açıklamaz. Bu olguda “Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.” ve “Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.” ipuçları klinik karar açısından Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Galaktozun glukoz-1-fosfata dönüşümü: Galaktozun glukoz-1-fosfata dönüşümü galaktoz metabolizmasıyla ilişkilidir; hipoketotik hipoglisemi mekanizması değildir. Bu olguda “Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.” ve “Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.” ipuçları klinik karar açısından Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Homosisteinin metiyonine remetilasyonu: Homosisteinin metiyonine remetilasyonu homosistein metabolizmasıyla ilgilidir; uzun zincir yağ asidi taşınmasını açıklamaz. Bu olguda “Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.” ve “Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.” ipuçları klinik karar açısından Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Açlıkta hipoglisemi ve kas ağrısı olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.” ve “Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.” birlikte okunduğunda Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması seçeneği öne çıkar; “Kreatin kinaz yüksekliği kas hasarını destekler.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uzun zincirli yağ asitlerinin beta oksidasyona girebilmesi için karnitin taşıma sistemiyle mitokondri matriksine alınması gerekir. Bu süreç bozulduğunda açlık ve egzersizde hipoketotik hipoglisemi, kas ağrısı ve rabdomiyoliz gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.”, “Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.” ve “Kreatin kinaz yüksekliği kas hasarını destekler.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine taşınması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ataklar açlık ve uzun egzersiz sonrası gelişmektedir.

Kanıt 2: Hipoglisemiye rağmen keton düzeyi düşüktür.

Kanıt 3: Kreatin kinaz yüksekliği kas hasarını destekler.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Uzun zincir yağ asidi oksidasyonu için karnitin taşıma sistemi gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 248: v187-new-248-yenidoganda-tatli-kokulu-idrar

Başlık: Yenidoğanda tatlı kokulu idrar

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Akçaağaç şurubu idrar hastalığında dallı zincirli amino asit katabolizma defektini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, emmede azalma, letarji ve idrarda tatlı koku nedeniyle yatırılıyor. Doğumdan sonraki ilk günlerde normal olduğu, beslenme arttıkça kusma, uykuya eğilim ve iritabilite geliştiği öğreniliyor. Akraba evliliği vardır.

Demografi: 6 günlük erkek yenidoğan | Setting: yenidoğan yoğun bakımda değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 158/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 2,26 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve hipotoniktir.
- Solunumu düzensizdir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma amino asit analizi

Etiket: Plazma amino asit analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lösin, izolösin ve valin düzeyleri yüksek saptandı. | Klinik anlam: Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma amino asit analizi | Sonuç özeti: Lösin, izolösin ve valin düzeyleri yüksek saptandı. | Yorum: Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Plazma amino asit analizi / Lösin, izolösin ve valin düzeyleri yüksek saptandı. // Dallı zincirli amino asit metabolizması bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel enzim kompleksi defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği
- B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
- C) Sistationin beta-sentaz eksikliği
- D) Homogentizat oksidaz eksikliği
- E) Glukoz-6-fosfataz eksikliği

Doğru Cevap: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği

A) Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği: Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği dallı zincirli amino asit birikimi ve tatlı kokulu idrar tablosunu açıklar. Vakadaki “Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüriye neden olur; dallı zincirli amino asit artışı yapmaz. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Sistationin beta-sentaz eksikliği: Sistationin beta-sentaz eksikliği homosistinüri yapar; lens subluksasyonu ve tromboz eğilimi beklenir. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Homogentizat oksidaz eksikliği: Vakadaki Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir ve İdrarda tatlı koku tariflenmiştir. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği Von Gierke hastalığına neden olur; açlık hipoglisemisi ve hepatomegali ön plandadır. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda tatlı kokulu idrar olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.” ve “İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.” birlikte okunduğunda Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği seçeneği öne çıkar; “Lösin, izolösin ve valin düzeyleri yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini

artırır.

Rationale: Tatlı kokulu idrar, yenidoğan döneminde beslenmeyle kötüleşen nörolojik bulgular ve lösin-izolösin-valin artışı akçaağaç şurubu idrar hastalığını düşündürür. Temel defekt dalı zincirli alfa-ketoasit dehidrogenaz kompleksindedir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.”, “İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.” ve “Lösin, izolösin ve valin düzeyleri yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Branched-chain alpha-ketoacid dehydrogenase eksikliği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Semptomlar yenidoğan döneminde beslenme arttıkça gelişmiştir.

Kanıt 2: İdrarda tatlı koku tariflenmiştir.

Kanıt 3: Lösin, izolösin ve valin düzeyleri yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: MSUD’de lösin, izolösin ve valin yıkımı bozulur; toksik nörolojik bulgular gelişir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 249: v187-new-249-antibiyotik-sonrasi-sulu-ishal

Başlık: Antibiyotik sonrası sulu ishal

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla ilişkilendirme.

Learning Target: Psöd membranöz kolitte Clostridioides difficile toksinlerini antibiyotik kullanımıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, hastanede antibiyotik tedavisi sonrası başlayan sulu ishal ve karın ağrısı nedeniyle değerlendiriliyor. Pnömoni nedeniyle geniş spektrumlu antibiyotik kullandığı, tedavinin beşinci gününde günde 8-10 kez sulu dışkılama başladığı öğreniliyor. Ateş ve kramp tarzı karın ağrısı eşlik etmektedir.

Demografi: 72 yaşında kadın hasta | Setting: enfeksiyon hastalıkları servisinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 38.2°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdı yüksek)

Fizik Muayene

- Batında yaygın hassasiyet vardır ancak rijidite yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Dışkıda toksin testi

Etiket: Dışkıda toksin testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Clostridioides difficile toksin A/B pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni destekler. | Sonuç yorumu: Etkeni destekler. | Sonuç başlığı: Dışkıda toksin testi | Sonuç özeti: Clostridioides difficile toksin A/B pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni destekler. | Satırlar: Dışkıda toksin testi / Clostridioides difficile toksin A/B pozitif saptandı. // Etkeni destekler.

Tetkik 2: Kolonoskopi

Etiket: Kolonoskopi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Kolon mukozasında sarı-beyaz plak benzeri psöd membranlar izlendi. | Klinik anlam: Psöd membranöz kolit lehinedir. | Sonuç yorumu: Psöd membranöz kolit lehinedir. | Sonuç başlığı: Kolonoskopi | Sonuç özeti: Kolon mukozasında sarı-beyaz plak benzeri psöd membranlar izlendi. | Yorum: Psöd membranöz kolit lehinedir. | Satırlar: Kolonoskopi / Kolon mukozasında sarı-beyaz plak benzeri psöd membranlar izlendi. // Psöd membranöz kolit lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-127 | Başlık: Kolonoskopi | Modalite: endoscopy | Bulgu: Kolon mukozasında sarı-beyaz plak benzeri psöd membranlar izlendi. | Klinik anlam: Psöd membranöz kolit lehinedir. | URL: https://iukbtlkzxtctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/127_psodmembranoz_kolit_kolonoskopi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/127_psodmembranoz_kolit_kolonoskopi.webp | Alt text: Kolonoskopi - Kolon mukozasında sarı-beyaz plak benzeri psöd membranlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Clostridioides difficile
B) Vibrio cholerae
C) Entamoeba histolytica
D) Salmonella Typhi
E) Giardia intestinalis

Doğru Cevap: Clostridioides difficile

- A) Clostridioides difficile: Clostridioides difficile antibiyotik sonrası toksin aracılı psöd membranöz kolit tablosuyla en uyumlu etkindir. Vakadaki “İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.” ve “Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Vibrio cholerae: Vibrio cholerae piriñ suyu görünümünde bol sulu ishal yapar; psöd membran ve antibiyotik ilişkisi tipik değildir. Bu olguda “İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.” ve “Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.” ipuçları tanısar karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Entamoeba histolytica: Entamoeba histolytica kanlı dizanteri ve karaciğer apsesiyle ilişkilidir; toksin A/B pozitifliği yapmaz. Bu olguda “İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.” ve “Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.” ipuçları tanısar karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Salmonella Typhi: Salmonella Typhi enterik ateş yapar; antibiyotik sonrası psöd membranöz kolitin tipik nedeni değildir. Bu olguda “İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.” ve “Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.” ipuçları tanısar karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Giardia intestinalis: Giardia intestinalis yağlı-kötü kokulu malabsorptif ishal yapar; kolonik psöd membran beklenmez. Bu olguda “İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.” ve “Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.” ipuçları tanısar karar açısından Clostridioides difficile seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antibiyotik sonrası sulu ishal olgusunda klinik karar tanısar karar üzerine kuruludur. “İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.” ve “Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Clostridioides difficile seçeneği öne çıkar; “Kolonoskopide psöd membranlar görölmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Geniş spektrumlu antibiyotik sonrası sulu ishal, ateş, karın ağrısı, toksin A/B pozitifliği ve psöd membranlar Clostridioides difficile kolitini düşündürür. Toksinler kolon mukozasında inflamasyon ve psöd membran oluşumuna yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.”, “Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.” ve “Kolonoskopide psöd membranlar görölmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Clostridioides difficile en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: İshal geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı sonrasında başlamıştır.

Kanıt 2: Dışkıda toksin A/B pozitif saptanmıştır.

Kanıt 3: Kolonoskopide psöd membranlar görölmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Antibiyotik sonrası psödomembranöz kolitin klasik etkeni Clostridioides difficile'dir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 250: v187-new-250-hemolitik-hastada-ani-anemi

Başlık: Hemolitik hastada ani anemi

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla ilişkilendirme.

Learning Target: Parvovirus B19 enfeksiyonunu aplastik kriz ve eritroid öncül tropizmiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, orak hücreli anemi zemininde ani halsizlik ve solukluk nedeniyle getiriliyor. Son hafta hafif ateş ve yüzde döküntü geçirdiği, ardından belirgin halsizlik ve çarpıntı geliştiği öğreniliyor. Ağrılı kriz bulgusu belirgin değildir.

Demografi: 12 yaşında erkek çocuk | Setting: hematoloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 98/60 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,20 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk soluk ve halsizdir.
- Sarılık bazal düzeyine göre artmamıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Bazal değerine göre belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Akut anemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Akut anemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Bazal değerine göre belirgin düşük saptandı. | Yorum: Akut anemiyi gösterir. | Satırlar: Hemoglobin / Bazal değerine göre belirgin düşük saptandı. / 5.6 g/dL / Akut anemiyi gösterir.

Tetkik 2: Retikülosit sayısı

Etiket: Retikülosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Aplastik krizi destekler. | Sonuç yorumu: Aplastik krizi destekler. | Sonuç başlığı: Retikülosit sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Aplastik krizi destekler. | Satırlar: Retikülosit sayısı / Belirgin düşük saptandı. / / Aplastik krizi destekler.

Tetkik 3: Parvovirus B19 IgM

Etiket: Parvovirus B19 IgM | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Akut enfeksiyonu destekler. | Sonuç yorumu: Akut enfeksiyonu destekler. | Sonuç başlığı: Parvovirus B19 IgM | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Akut enfeksiyonu destekler. | Satırlar: Parvovirus B19 IgM / Pozitif saptandı. / / Akut enfeksiyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablonun en olası etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parvovirus B19
B) Epstein-Barr virus
C) Cytomegalovirus
D) Rabies virus
E) Rotavirus

Doğru Cevap: Parvovirus B19

- A) Parvovirus B19: Parvovirus B19 eritroid öncülleri hedefleyerek retikülosit düşüklüğüyle seyreden aplastik kriz oluşturur. Vakadaki “Çocukta orak hücreli anemi vardır.” ve “Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Epstein-Barr virus: Epstein-Barr virus enfeksiyöz mononükleoz yapar; eritroid aplazi ve retikülosit düşüklüğünün tipik etkeni değildir. Bu olguda “Çocukta orak hücreli anemi vardır.” ve “Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Parvovirus B19 seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Cytomegalovirus: Cytomegalovirus immünsüpre hastalarda ağır enfeksiyon yapabilir ancak orak hücreli çocukta klasik aplastik kriz etkeni değildir. Bu olguda “Çocukta orak hücreli anemi vardır.” ve “Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Parvovirus B19 seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Rabies virus: Rabies virus nörotropik enfeksiyon ve hidrofobiyle ilişkilidir; eritropoez baskılanmasını açıklamaz. Bu olguda “Çocukta orak hücreli anemi vardır.” ve “Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Parvovirus B19 seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Rotavirus: Vakadaki Çocukta orak hücreli anemi vardır ve Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır. Bu olguda “Çocukta orak hücreli anemi vardır.” ve “Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Parvovirus B19 seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hemolitik hastada ani anemi olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Çocukta orak hücreli anemi vardır.” ve “Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.” birlikte okunduğunda Parvovirus B19 seçeneği öne çıkar; “Parvovirus B19 IgM pozitif saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Parvovirus B19 eritroid öncülleri enfekte ederek geçici eritropoez durmasına neden olur. Kronik hemolitik hastalığı olan çocukta ani ağır anemi ve retikülosit düşüklüğü aplastik krizi düşündürür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta orak hücreli anemi vardır.”, “Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.” ve “Parvovirus B19 IgM pozitif saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Parvovirus B19 en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Çocukta orak hücreli anemi vardır.

Kanıt 2: Hemoglobin bazale göre belirgin düşmüş, retikülosit sayısı azalmıştır.

Kanıt 3: Parvovirus B19 IgM pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Parvovirus B19 kronik hemolitik hastalığı olanlarda aplastik kriz yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 251: v187-new-251-boyunda-agrisiz-lenf-nodu

Başlık: Boyunda ağrısız lenf nodu

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik paterni klinik tabloyla ilişkilendirme.

Learning Target: Hodgkin lenfomada Reed-Sternberg hücrelerini ve klinik paterni tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, boyunda giderek büyüyen ağrısız şişlik ve gece terlemesi nedeniyle başvuruyor. Son üç ayda kilo kaybı, aralıklı ateş ve gece terlemesi olduğunu belirtmektedir. Enfeksiyon odağı tariflenmemektedir.

Demografi: 28 yaşında erkek hasta | Setting: hematoloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Sol servikal bölgede lastik kıvamında, ağrısız lenf nodu palpe edilir.
- Hepatosplenomegali belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi

Etiket: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Geniş eozinofilik sitoplazmalı, çift çekirdekli ve belirgin nükleollü Reed-Sternberg hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Hodgkin lenfoma lehine tanısız bulgudur. | Sonuç yorumu: Hodgkin lenfoma lehine tanısız bulgudur. | Sonuç başlığı: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi | Sonuç özeti: Geniş eozinofilik sitoplazmalı, çift çekirdekli ve belirgin nükleollü Reed-Sternberg hücreleri izlendi. | Yorum: Hodgkin lenfoma lehine tanısız bulgudur. | Satırlar: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi / Geniş eozinofilik sitoplazmalı, çift çekirdekli ve belirgin nükleollü Reed-Sternberg hücreleri izlendi. / / Hodgkin lenfoma lehine tanısız bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-128 | Başlık: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Geniş eozinofilik sitoplazmalı, çift çekirdekli ve belirgin nükleollü Reed-Sternberg hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Hodgkin lenfoma lehine tanısız bulgudur. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/128_hodgkin_lenfoma_reed_sternberg_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/128_hodgkin_lenfoma_reed_sternberg_histopatoloji.webp | Alt text: Eksizyonel lenf nodu biyopsisi - Geniş eozinofilik sitoplazmalı, çift çekirdekli ve belirgin nükleollü Reed-Sternberg hücreleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hodgkin lenfoma
B) Akut apandisit
C) Burkitt lenfoma
D) Multiple miyelom
E) Kronik miyeloid lösemi

Doğru Cevap: Hodgkin lenfoma

A) Hodgkin lenfoma: Hodgkin lenfoma ağrısız servikal lenfadenopati, B semptomları ve Reed-Sternberg hücreleriyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır." ve "Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleşir.
B) Akut apandisit: Akut apandisit sağ alt kadranda ağrı ve transmurall nötrofil infiltrasyonu ile ilişkilidir; servikal lenf nodu biyopsisini açıklamaz. Bu olguda "Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır." ve "Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Hodgkin lenfoma seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Burkitt lenfoma: Burkitt lenfomada yıldızlı gökyüzü görünümü ve MYC ilişkisi beklenir; Reed-Sternberg hücreleri klasik değildir. Bu olguda "Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır." ve "Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Hodgkin lenfoma seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Multiple miyelom: Multiple miyelom plazma hücre neoplazmasıdır ve kemik ağrısı, hiperkalsemi veya M proteiniyle düşünülür. Bu olguda "Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır." ve "Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Hodgkin lenfoma seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Kronik miyeloid lösemi: Kronik miyeloid lösemi lökositoz ve BCR-ABL füzyonu ile ilişkilidir; Reed-Sternberg hücreli nodal patern değildir. Bu olguda "Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır." ve "Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir." ipuçları tanısız karar açısından Hodgkin lenfoma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Boyunda ağrısız lenf nodu olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır." ve "Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir." birlikte okunduğunda Hodgkin lenfoma seçeneği öne çıkar; "Biyopside Reed-Sternberg hücreleri izlenmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağrısız servikal lenfadenopati, B semptomları ve biyopside Reed-Sternberg hücreleri Hodgkin lenfomayı düşündürür. Reed-Sternberg hücreleri klasik olarak CD15 ve CD30 pozitif olabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.", "Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir." ve "Biyopside Reed-Sternberg hücreleri izlenmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hodgkin lenfoma en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada ağrısız servikal lenfadenopati vardır.

Kanıt 2: Gece terlemesi, ateş ve kilo kaybı tariflenmiştir.

Kanıt 3: Biyopside Reed-Sternberg hücreleri izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Hodgkin lenfomada Reed-Sternberg hücreleri tanısız ipucudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 252: v187-new-252-kalp-ilaci-sonrasi-bulanti-ve-gorme-bozuklugu

Başlık: Kalp ilacı sonrası bulantı ve görme bozukluğu

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Digoksin toksisitesinde hiperkalemi, görme bulguları ve antidot tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bulantı, iştahsızlık, sarı-yeşil görme ve çarpıntı nedeniyle acile getiriliyor. Kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon nedeniyle digoksin kullandığı öğreniliyor. Son günlerde böbrek fonksiyonlarının bozulduğu ve ilacını düzenli almaya devam ettiği belirtiliyor.

Demografi: 78 yaşında kadın hasta | Setting: acil serviste değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/62 mmHg | Nabız: 48/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,46

Fizik Muayene

- Hasta halsizdir.
- Nabız düzensiz ve 48/dk'dır.
- Görme yakınmasını sarımsı görme olarak tarifler.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum digoksin düzeyi

Etiket: Serum digoksin düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Klinik anlam: Digoksin toksisitesini destekler. | Sonuç yorumu: Digoksin toksisitesini destekler. | Sonuç başlığı: Serum digoksin düzeyi | Sonuç özeti: Toksik düzeyde yüksek saptandı. | Yorum: Digoksin toksisitesini destekler. | Satırlar: Serum digoksin düzeyi / Toksik düzeyde yüksek saptandı. / 3.4 ng/mL / 0.5-2.0 ng/mL

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Na/K ATPaz inhibisyonu ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Na/K ATPaz inhibisyonu ile uyumludur. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Na/K ATPaz inhibisyonu ile uyumludur. | Satırlar: Serum potasyum / Yüksek saptandı. / 5.9 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L

Tetkik 3: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve iletim bozukluğu izlendi. | Klinik anlam: Kardiyak toksisiteyi destekler. | Sonuç yorumu: Kardiyak toksisiteyi destekler. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve iletim bozukluğu izlendi. | Yorum: Kardiyak toksisiteyi destekler. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve iletim bozukluğu izlendi. / / Kardiyak toksisiteyi destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-129 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve iletim bozukluğu izlendi. | Klinik anlam: Kardiyak toksisiteyi destekler. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/129_digoksin_toksitesisi_ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/129_digoksin_toksitesisi_ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Yavaş ventrikül yanıtı düzensiz ritim ve iletim bozukluğu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun spesifik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi
B) Beta-2 agonist inhalasyonu
C) Vitamin K verilmesi
D) Protamin sülfat verilmesi
E) Flumazenil verilmesi

Doğru Cevap: Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi

- A) Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi: Digoksin spesifik antikor fragmanı ciddi digoksin toksisitesinde ilacı bağlayarak kardiyak ve sistemik toksisiteyi hedefler. Vakadaki “Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.” ve “Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Beta-2 agonist inhalasyonu: Beta-2 agonist inhalasyonu bronkospazm tedavisinde kullanılır; digoksin toksisitesinin antidotu değildir. Bu olguda “Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.” ve “Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Vitamin K verilmesi: Vitamin K warfarin etkisini geri çevirmek için kullanılır; digoksin toksisitesini tedavi etmez. Bu olguda “Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.” ve “Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Protamin sülfat verilmesi: Vakadaki Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur ve Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır. Bu olguda “Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.” ve “Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Flumazenil verilmesi: Flumazenil benzodiazepin antagonisti olarak kullanılır; digoksin kaynaklı aritmi ve görme bulgularını tedavi etmez. Bu olguda “Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.” ve “Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kalp ilacı sonrası bulantı ve görme bozukluğu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.” ve “Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.” birlikte okunduğunda Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi seçeneği öne çıkar; “Serum digoksin ve potasyum düzeyleri yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Digoksin toksisitesinde gastrointestinal yakınmalar, sarı-yeşil görme, bradikardi/aritmi ve hiperkalemi görülebilir. Ciddi toksisite veya hayatı tehdit eden aritmi/hiperkalemi varlığında digoksin spesifik antikor fragmanı kullanılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.”, “Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.” ve “Serum digoksin ve potasyum düzeyleri yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Digoksin spesifik antikor fragmanı verilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta digoksin kullanmaktadır ve böbrek fonksiyonu bozulmuştur.

Kanıt 2: Sarımsı görme, bulantı ve bradikardi vardır.

Kanıt 3: Serum digoksin ve potasyum düzeyleri yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağına yerine geçmez.

Exam Pearl: Ciddi digoksin toksisitesinde spesifik antidot digoksin antikor fragmanıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 253: v187-new-253-siddetli-karin-agrisi-ve-hafif-muayene-bulgusu

Başlık: Şiddetli karın ağrısı ve hafif muayene bulgusu

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tanıyı klinik, muayene ve objektif bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Mezenter iskemi şüphesinde ağrı-muayene uyumsuzluğu ve acil tanısal yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan şiddetli karın ağrısı ve bulantı nedeniyle acile başvuruyor. Atriyal fibrilasyon öyküsü vardır ve antikoagülanını düzensiz kullandığı öğreniliyor. Ağrının çok şiddetli olduğunu ancak başlangıçta karın muayenesinin çok belirgin olmadığını belirtmektedir.

Demografi: 76 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste genel cerrahi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 102/64 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,82

Fizik Muayene

- Hasta huzursuz ve ağrılıdır.
- Batında yaygın hafif hassasiyet vardır ancak erken dönemde belirgin defans yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Doku hipoperfüzyonu ve iskemi açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Doku hipoperfüzyonu ve iskemi açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Doku hipoperfüzyonu ve iskemi açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Serum laktat / Yüksek saptandı. / 5.1 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut mezenter iskemi
B) Basit viral gastroenterit
C) İrritabl bağırsak sendromu
D) Akut sistit
E) Safra koliği

Doğru Cevap: Akut mezenter iskemi

A) Akut mezenter iskemi: Akut mezenter iskemi atriyal fibrilasyon, orantısız karın ağrısı ve laktat yüksekliğiyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.” ve “Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleşir.

B) Basit viral gastroenterit: Viral gastroenterit genellikle ishal ve kramp tarzı ağrı yapar; laktat yüksekliği ve emboli riski açıklanamaz. Bu olguda “Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.” ve “Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut mezenter iskemi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) İrritabl bağırsak sendromu: İrritabl bağırsak sendromu kronik fonksiyonel yakınmalarla seyreder; ani şiddetli ağrı ve laktat yüksekliği beklenmez. Bu olguda “Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.” ve “Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut mezenter iskemi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Akut sistit: Vakadaki Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır ve Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir. Bu olguda “Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.” ve “Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut mezenter iskemi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Safra koliği: Safra koliği sağ üst kadranda ağrısıyla seyreder; atriyal fibrilasyon ve orantısız yaygın ağrı mezenter iskemi lehinedir. Bu olguda “Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.” ve “Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ipuçları tanısal karar açısından Akut mezenter iskemi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Şiddetli karın ağrısı ve hafif muayene bulgusu olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.” ve “Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.” birlikte okunduğunda Akut mezenter iskemi seçeneği öne çıkar; “Serum laktat düzeyi yüksektir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Atriyal fibrilasyon zemininde ani başlayan, muayene bulgularına göre orantısız şiddetli karın ağrısı ve laktat yüksekliği akut mezenter iskemiye düşündürür. Erken tanı ve acil damar görüntüleme-cerrahi değerlendirme bağırsak nekrozunu önlemek için kritiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.”, “Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.” ve “Serum laktat düzeyi yüksektir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut mezenter iskemi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada atriyal fibrilasyon ve düzensiz antikoagülan kullanımı vardır.

Kanıt 2: Karın ağrısı ani ve muayene bulgularına göre orantısız şiddettedir.

Kanıt 3: Serum laktat düzeyi yüksektir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Mezenter iskemide erken dönemde ağrı şiddetli, muayene bulguları görece silik olabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 254: v187-new-254-bas-dogduktan-sonra-omuzlarin-takilmasi

Başlık: Baş doğduktan sonra omuzların takılması

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Omuz distosisinde ilk manevrayı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Fetal baş doğduktan sonra omuzların doğmaması nedeniyle obstetrik ekip müdahale için çağrılıyor. Gestasyonel diyabet öyküsü vardır ve son ultrasonda fetüsün iri olduğu belirtilmiştir. Doğum eylemi sırasında baş doğmuş ancak hafif traksiyona rağmen omuzlar ilerlememiştir.

Demografi: 30 yaşında gebe hasta | Setting: doğumhanede vajinal doğum sırasında değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fetal baş perinede retrakte görünmektedir.
- Uterin kontraksiyonlar devam etmektedir.
- Anne hemodinamik olarak stabildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu durumda ilk uygulanması gereken manevra aşağıdakilerden hangisidir?

- A) McRoberts manevrası ve suprapubik bası
B) Fundal bası uygulamak
C) Acil vakumla başı tekrar çekmek
D) Metotreksat vermek
E) Dijital servikal dilatasyon yapmak

Doğru Cevap: McRoberts manevrası ve suprapubik bası

- A) McRoberts manevrası ve suprapubik bası: McRoberts manevrası ve suprapubik bası omuz distosisinde anterior omuzu serbestleştirmek için ilk uygulanacak yaklaşımdır. Vakadaki “Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.” ve “Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Fundal bası uygulamak: Vakadaki Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir ve Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur. Bu olguda “Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.” ve “Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.” ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Acil vakumla başı tekrar çekmek: Vakumla başa traksiyonu artırmak brakial pleksus hasarı riskini artırır ve doğru ilk yaklaşım değildir. Bu olguda “Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.” ve “Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.” ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Metotreksat vermek: Vakadaki Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir ve Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur. Bu olguda “Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.” ve “Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.” ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Dijital servikal dilatasyon yapmak: Vakadaki Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir ve Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur. Bu olguda “Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.” ve “Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.” ipuçları tedavi önceliği açısından McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Baş doğduktan sonra omuzların takılması olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.” ve “Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.” birlikte okunduğunda McRoberts manevrası ve suprapubik bası seçeneği öne çıkar; “Fetal başta perineye retraksiyon görünümü vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Fetal başın doğup omuzların takılması omuz distosisidir. İlk yaklaşım yardım çağırarak, traksiyonu artırmamak, McRoberts manevrası ve suprapubik bası uygulamaktır; fundal bası omuz sıkışmasını kötüleştirebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.”, “Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.” ve “Fetal başta perineye retraksiyon görünümü vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle McRoberts manevrası ve suprapubik bası en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Fetal baş doğmuş ancak omuzlar ilerlememiştir.

Kanıt 2: Gestasyonel diyabet ve iri fetüs öyküsü risk oluşturur.

Kanıt 3: Fetal başta perineye retraksiyon görünümü vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Omuz distosisinde ilk manevra McRoberts ve suprapubik basıdır; fundal bası yapılmaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 255: v187-new-255-yasli-hastada-yeni-bas-agrisi

Başlık: Yaşlı hastada yeni baş ağrısı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Temporal arteritte görme kaybını önlemek için steroid tedavisini biyopsi beklemeden başlatabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yeni başlayan temporal baş ağrısı, çene yorulması ve görme bulanıklığı nedeniyle başvuruyor. Son üç haftadır sağ şakakta hassasiyet ve saç tararken ağrı olduğunu, yemek yerken çenesinin yorulduğunu belirtmektedir. Bugün sağ gözde geçici görme bulanıklığı yaşamıştır.

Demografi: 73 yaşında kadın hasta | Setting: acil serviste nöroloji ve romatoloji tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.6°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Sağ temporal arter hassas ve kalınlaşmış palpe edilir.
- Görme keskinliği sağ gözde hafif azalmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Eritrosit sedimentasyon hızı

Etiket: Eritrosit sedimentasyon hızı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Vaskülitik inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Vaskülitik inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Eritrosit sedimentasyon hızı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Vaskülitik inflamasyonu destekler. | Satırlar: Eritrosit sedimentasyon hızı / Yüksek saptandı. / 92 mm/saat / <30 mm/saat

Tetkik 2: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aktif inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Aktif inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Aktif inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / Yüksek saptandı. / 64 mg/L / <5 mg/L

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun ilk yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak
- B) Parasetamol verip poliklinik kontrolü önermek
- C) Antibiyotik başlanıp kültür sonucu izlem planlamak
- D) Antikoagülan başlanıp steroidleri ertelemek
- E) Acil lomber ponksiyon yapmak

Doğru Cevap: Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak

A) Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak: Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak görme kaybı riski olan dev hücreli arteritte doğru ilk yaklaşımdır. Vakadaki “Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Parasetamol verip poliklinik kontrolü önermek: Vakadaki Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır ve Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir. Bu olguda “Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Antibiyotik başlanıp kültür sonucu izlem planlamak: Vakadaki Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır ve Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir. Bu olguda “Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Antikoagülan başlanıp steroidleri ertelemek: Vakadaki Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır ve Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir. Bu olguda “Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Acil lomber ponksiyon yapmak: Vakadaki Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır ve Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir. Bu olguda “Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yaşlı hastada yeni baş ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.” ve “Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” birlikte okunduğunda Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak seçeneği öne çıkar; “Geçici görme bulanıklığı ve yüksek inflamasyon belirteçleri vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı hastada yeni temporal baş ağrısı, çene klodikasyonu, temporal arter hassasiyeti, yüksek inflamasyon belirteçleri ve geçici görme bulanıklığı dev hücreli arteriti düşündürür. Kalıcı görme kaybını önlemek için kortikosteroid tedavi biyopsi sonucu beklenmeden başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.”, “Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.” ve “Geçici görme bulanıklığı ve yüksek inflamasyon belirteçleri vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Temporal arter biyopsisi sonucunu beklemeden yüksek doz kortikosteroid başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta 50 yaş üzerindedir ve yeni temporal baş ağrısı vardır.

Kanıt 2: Çene klodikasyonu ve temporal arter hassasiyeti tariflenmiştir.

Kanıt 3: Geçici görme bulanıklığı ve yüksek inflamasyon belirteçleri vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk başamayı yerine geçmez.

Exam Pearl: Dev hücreli arterit şüphesinde görme kaybını önlemek için steroid biyopsi beklenmeden başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 256: v188-new-256-kalca-travmasi-sonrasi-yuruyememe

Başlık: Kalça travması sonrası yürüyememe

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulguyla ilişkilendirme.

Learning Target: Femur boynu kırığında arteria circumflexa femoris medialis hasarını femur başı avasküler nekrozu riskiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, evde düşme sonrası sağ kalça ağrısı ve üzerine basamama nedeniyle başvuruyor. Düşerken sağ kalçasının üzerine çarptığını, olaydan sonra ayağa kalkamadığını ve sağ kasık bölgesinde şiddetli ağrı hissettiğini belirtmektedir. Osteoporoz öyküsü vardır.

Demografi: 72 yaşında kadın hasta | Setting: acil serviste ortopedi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ alt ekstremitte dış rotasyonda ve kısalmış görünmektedir.
- Sağ kalça hareketleri ağrılıdır.
- Distal nabızlar alınmaktadır ve ayak bileği hareketleri korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Pelvis ve kalça grafisi

Etiket: Pelvis ve kalça grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ femur boynunda deplase intrakapsüler kırık izlendi. | Klinik anlam: Femur başı kanlanması açısından riskli kırık tipidir. | Sonuç yorumu: Femur başı kanlanması açısından riskli kırık tipidir. | Sonuç başlığı: Pelvis ve kalça grafisi | Sonuç özeti: Sağ femur boynunda deplase intrakapsüler kırık izlendi. | Yorum: Femur başı kanlanması açısından riskli kırık tipidir. | Satırlar: Pelvis ve kalça grafisi / Sağ femur boynunda deplase intrakapsüler kırık izlendi. // Femur başı kanlanması açısından riskli kırık tipidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-130 | Başlık: Pelvis ve kalça grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ femur boynunda deplase intrakapsüler kırık izlendi. | Klinik anlam: Femur başı kanlanması açısından riskli kırık tipidir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/130_femur_boynu_kirigi_pelvis_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/130_femur_boynu_kirigi_pelvis_grafisi.webp | Alt text: Pelvis ve kalça grafisi - Sağ femur boynunda deplase intrakapsüler kırık izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu kırıkta femur başı avasküler nekrozu açısından en kritik arter aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Arteria circumflexa femoris medialis
B) Arteria obturatoria
C) Arteria glutea superior
D) Arteria pudenda interna
E) Arteria tibialis anterior

Doğru Cevap: Arteria circumflexa femoris medialis

- A) Arteria circumflexa femoris medialis: Arteria circumflexa femoris medialis femur başının ana retinaküler kanlanmasını sağladığı için deplase femur boynu kırığında en kritik damardır. Vakadaki “Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.” ve “Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Arteria obturatoria: Arteria obturatoria ligamentum capitis femoris daliyla katkı sağlayabilir ancak erişkinde femur başının ana kanlanması değildir. Bu olguda “Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.” ve “Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Arteria circumflexa femoris medialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Arteria glutea superior: Arteria glutea superior gluteal bölgeyi besler ve femur başı avasküler nekroz riskinde temel damar değildir. Bu olguda “Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.” ve “Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Arteria circumflexa femoris medialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Arteria pudenda interna: Arteria pudenda interna perineal yapıların kanlanmasıyla ilişkilidir; femur başı retinaküler dolaşımını açıklamaz. Bu olguda “Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.” ve “Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Arteria circumflexa femoris medialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Arteria tibialis anterior: Arteria tibialis anterior bacağın anterior kompartmanını besler; kalça eklemi ve femur başı kanlanmasıyla ilişkili değildir. Bu olguda “Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.” ve “Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Arteria circumflexa femoris medialis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kalça travması sonrası yürüyememe olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.” ve “Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.” birlikte okunduğunda Arteria circumflexa femoris medialis seçeneği öne çıkar; “Hasta kalça travması sonrası üzerine basamamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Femur başının erişkindeki ana kanlanması arteria circumflexa femoris medialisin retinaküler dallarıyla sağlanır. Deplase intrakapsüler femur boynu kırıklarında bu dallar hasarlanabilir ve femur başı avasküler nekrozu gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.”, “Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.” ve “Hasta kalça travması sonrası üzerine basamamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Arteria circumflexa femoris medialis en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kırık femur boynunda ve intrakapsüler yerleşimdedir.

Kanıt 2: Kırık deplasedir ve femur başı kanlanmasını bozma riski taşır.

Kanıt 3: Hasta kalça travması sonrası üzerine basamamaktadır.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguya uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Erişkinde femur başı kanlanması en çok arteria circumflexa femoris medialisin retinaküler dallarına bağlıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 257: v188-new-257-parotis-kitlesi-ameliyati-sonrasi-yuz-asimetrisi

Başlık: Parotis kitlesi ameliyatı sonrası yüz asimetrisi

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomi yapıyı klinik bulguyla ilişkilendirme.

Learning Target: Parotis cerrahisinde nervus facialis dallarının hasarını mimik kas kaybıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, parotis bezi ameliyatı sonrası ağız köşesinde düşüklük ve gözünü tam kapatamama nedeniyle başvuruyor. Sağ parotis kitlesi nedeniyle yüzeysel parotidektomi geçirdiği öğreniliyor. Ameliyat öncesi yüz hareketlerinde asimetri olmadığını belirtmektedir.

Demografi: 58 yaşında erkek hasta | Setting: kulak burun boğaz polikliniğinde postoperatif kontrolde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ göz kapanması zayıftır, sağ ağız köşesi aşağı sarkmıştır ve alın kırıştırma hareketi azalmıştır.
- Dil deviasyonu yoktur.
- Çiğneme kuvveti korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada etkilenmesi en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus trigeminus
- B) Nervus facialis
- C) Nervus glossopharyngeus
- D) Nervus hypoglossus
- E) Nervus accessorius

Doğru Cevap: Nervus facialis

- A) Nervus trigeminus: Nervus trigeminus çiğneme kasları ve yüz duyusuyla ilişkilidir; bu hastada çiğneme kuvveti korunmuştur. Bu olguda “Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Nervus facialis: Nervus facialis parotis içinde dallanır ve mimik kaslarını innerve ettiği için postoperatif yüz asimetrisini açıklar. Vakadaki “Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- C) Nervus glossopharyngeus: Nervus glossopharyngeus farinks duyusu ve yutma refleksiyle ilişkilidir; mimik kas paralizisini açıklamaz. Bu olguda “Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nervus hypoglossus: Vakadaki Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır ve Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır. Bu olguda “Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus accessorius: Nervus accessorius sternocleidomastoideus ve trapezius kaslarını innerve eder; yüz mimik kaybı yapmaz. Bu olguda “Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus facialis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Parotis kitlesi ameliyatı sonrası yüz asimetrisi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.” ve “Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.” birlikte okunduğunda Nervus facialis seçeneği öne çıkar; “Dil hareketleri ve çiğneme kuvveti korunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nervus facialis parotis bezi içinde dallanır ancak parotisi innerve etmez. Parotis cerrahisinde bu sinirin dalları hasarlanırsa mimik kaslarında güçsüzlük, göz kapatma kusuru ve ağız köşesinde düşme gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.”, “Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.” ve “Dil hareketleri ve çiğneme kuvveti korunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus facialis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yüz asimetrisi parotis cerrahisi sonrasında başlamıştır.

Kanıt 2: Göz kapatma, alın kırıştırma ve ağız köşesi hareketleri zayıflamıştır.

Kanıt 3: Dil hareketleri ve çiğneme kuvveti korunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Parotis cerrahisinde en kritik sinir nervus facialis dallarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 258: v188-new-258-akciger-embolisinde-oksijen-dusuklugu

Başlık: Akciğer embolisinde oksijen düşüklüğü

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğunda hipokseminin oksijenle düzelme eğilimini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani başlayan nefes darlığı ve batıcı göğüs ağrısı nedeniyle başvuruyor. Bir hafta önce uzun uçak yolculuğu yaptığı ve sonrasında sol bacakta şişlik fark ettiği öğreniliyor. Öksürük ve balgam tariflememektedir.

Demografi: 51 yaşında kadın hasta | Setting: acil serviste değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %88% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,00 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta takipneiktir.
- Akciğer oskültasyonunda belirgin ral yoktur.
- Sol baldırda hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: BT pulmoner anjiyografi

Etiket: BT pulmoner anjiyografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ alt lob segmenter pulmoner arter dalında dolum defekti izlendi. | Klinik anlam: Pulmoner emboli ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Pulmoner emboli ile uyumludur. | Sonuç başlığı: BT pulmoner anjiyografi | Sonuç özeti: Sağ alt lob segmenter pulmoner arter dalında dolum defekti izlendi. | Yorum: Pulmoner emboli ile uyumludur. | Satırlar: BT pulmoner anjiyografi / Sağ alt lob segmenter pulmoner arter dalında dolum defekti izlendi. // Pulmoner emboli ile uyumludur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-131 | Başlık: BT pulmoner anjiyografi | Modalite: ct | Bulgu: Sağ alt lob segmenter pulmoner arter dalında dolum defekti izlendi. | Klinik anlam: Pulmoner emboli ile uyumludur. | URL: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/131_pulmoner_emboli_bt_anjiyografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/131_pulmoner_emboli_bt_anjiyografi.webp | Alt text: BT pulmoner anjiyografi - Sağ alt lob segmenter pulmoner arter dalında dolum defekti izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki hipokseminin temel fizyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu
B) Saf sağdan sola intrakardiyak şant
C) Alveoler ventilasyonun tamamen durması
D) Hemoglobinin oksijeni irreversibl bağlaması
E) Diffüzyonun karbondioksit için tamamen durması

Doğru Cevap: Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu

A) Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu: Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu pulmoner embolide ventile olan ancak perfüzyonu azalan alveol bölgelerini açıklayan temel mekanizmadır. Vakadaki “Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.” ve “Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Saf sağdan sola intrakardiyak şant: Saf sağdan sola intrakardiyak şant oksijenle sınırlı düzelir; bu olguda vasküler obstrüksiyon kaynaklı V/Q uyumsuzluğu ön plandadır. Bu olguda “Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.” ve “Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Alveoler ventilasyonun tamamen durması: Alveoler ventilasyon tamamen durmamıştır çünkü akciğer oskültasyonu belirgin konsolidasyon veya tam obstrüksiyon göstermemektedir. Bu olguda “Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.” ve “Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Hemoglobinin oksijeni irreversibl bağlaması: Hemoglobin oksijeni fizyolojik olarak geri dönüşümlü bağlar; pulmoner embolide sorun hemoglobinin bağlanmasının irreversibl olması değildir. Bu olguda “Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.” ve “Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Diffüzyonun karbondioksit için tamamen durması: Karbondioksit difüzyonunun tamamen durması yaşamla uyumlu değildir ve pulmoner embolinin tipik mekanizması değildir. Bu olguda “Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.” ve “Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Akciğer embolisinde oksijen düşüklüğü olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.” ve “Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.” birlikte okunduğunda Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu seçeneği öne çıkar; “BT pulmoner anjiyografide pulmoner arter dalında dolum defekti izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Pulmoner embolide bazı alveoller ventile olmaya devam ederken perfüzyon azalır ve ölü boşluk ventilasyonu artar. Bu ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu hipoksemiye neden olur ve çoğu durumda oksijen desteğiyle kısmen düzelme beklenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.”, “Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.” ve “BT pulmoner anjiyografide pulmoner arter dalında dolum defekti izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğu en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada ani nefes darlığı ve taşikardi gelişmiştir.

Kanıt 2: Uzun yolculuk ve bacak şişliği tromboemboli riskini destekler.

Kanıt 3: BT pulmoner anjiyografide pulmoner arter dalında dolum defekti izlenmiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Pulmoner embolide hipokseminin ana mekanizması ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 259: v188-new-259-otonom-reseptor-yaniti

Başlık: Otonom reseptör yaniti

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Otonom sinir sisteminde sempatik preganglionik ve postganglionik nörotransmitter farkını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde sempatik sinir sistemi aktivasyonu sırasında ganglion ve hedef organ düzeyindeki nörotransmitterler tartışılıyor. Bilinen hastalığı veya ilaç kullanımı yoktur. Değerlendirme fizyolojik sinaptik iletim mekanizmasını anlamak için yapılmaktadır.

Demografi: 25 yaşında sağlıklı gönüllü | Setting: fizyoloji laboratuvarında otonom sinir sistemi yanıtları açısından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 116/72 mmHg | Nabız: 74/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,64

Fizik Muayene

- Fizik muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fizyolojik simülasyon

Etiket: Fizyolojik simülasyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sempatik preganglionik nöron ve damar düz kasına giden postganglionik nöron aktivasyonu modellendi. | Klinik anlam: Otonom nörotransmitter ayrımını değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç yorumu: Otonom nörotransmitter ayrımını değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç başlığı: Fizyolojik simülasyon | Sonuç özeti: Sempatik preganglionik nöron ve damar düz kasına giden postganglionik nöron aktivasyonu modellendi. | Yorum: Otonom nörotransmitter ayrımını değerlendirmek için kullanılmıştır. | Satırlar: Fizyolojik simülasyon / Sempatik preganglionik nöron ve damar düz kasına giden postganglionik nöron aktivasyonu modellendi. // Otonom nörotransmitter ayrımını değerlendirmek için kullanılmıştır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Damar düz kasını innerve eden tipik sempatik yolakta preganglionik ve postganglionik nöronların ana nörotransmitterleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asetilkolin ve norepinefrin
B) Norepinefrin ve asetilkolin
C) Dopamin ve serotonin
D) GABA ve glutamat
E) Histamin ve bradikinin

Doğru Cevap: Asetilkolin ve norepinefrin

- A) Asetilkolin ve norepinefrin: Asetilkolin ve norepinefrin tipik damar düz kasına giden sempatik yolakta doğru preganglionik ve postganglionik nörotransmitter sırasıdır. Vakadaki “Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.” ve “Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Norepinefrin ve asetilkolin: Norepinefrin ve asetilkolin sırası tipik sempatik ganglion-damar düz kası yollarında ters verilmiştir. Bu olguda “Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.” ve “Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Asetilkolin ve norepinefrin seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Dopamin ve serotonin: Dopamin ve serotonin otonom ganglion ile damar düz kası sempatik iletiminde temel çift değildir. Bu olguda “Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.” ve “Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Asetilkolin ve norepinefrin seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) GABA ve glutamat: GABA ve glutamat merkezi sinir sisteminde önemli nörotransmitterlerdir ancak tipik otonom sempatik efektör yolak çifti değildir. Bu olguda “Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.” ve “Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Asetilkolin ve norepinefrin seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Histamin ve bradikinin: Histamin ve bradikinin inflamatuvar mediyatörlerdir; sempatik preganglionik-postganglionik nörotransmitter sırasını açıklamaz. Bu olguda “Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.” ve “Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Asetilkolin ve norepinefrin seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Otonom reseptör yaniti olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.” ve “Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.” birlikte okunduğunda Asetilkolin ve norepinefrin seçeneği öne çıkar; “Hedef organ damar düz kasıdır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tipik sempatik yolakta preganglionik nöron ganglionda nikotinik reseptörlere asetilkolin salgılar. Damar düz kasına giden postganglionik sempatik nöron ise genellikle norepinefrin salgılayarak adrenerjik reseptörler üzerinden etki oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.”, “Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.” ve “Hedef organ damar düz kasıdır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Asetilkolin ve norepinefrin en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Simülasyon sempatik ganglion ve damar düz kası hedefini içermektedir.

Kanıt 2: Soru tipik sempatik preganglionik nöronu sorgulamaktadır.

Kanıt 3: Hedef organ damar düz kasıdır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Sempatik preganglionik lifler asetilkolin, çoğu sempatik postganglionik lif norepinefrin salgılar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 260: v188-new-260-karacigerde-fagositik-hucre

Başlık: Karaciğerde fagositik hücre

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Histolojik yapıyı klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Karaciğer sinüzoidinde Kupffer hücrelerini yerleşim ve işleviyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Karaciğer sinüzoidleri içinde yerleşen fagositik hücrelerin tanımlanması isteniyor. Hasta kronik karaciğer hastalığı açısından değerlendirilmiş ve biyopsi alınmıştır. Soru, biyopside görülen hücrelerin histolojik kimliğine yöneliktir.

Demografi: 48 yaşında erkek hasta | Setting: karaciğer biyopsisi raporu üzerinden histoloji eğitiminde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fizik muayenede hafif hepatomegali vardır.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Karaciğer biyopsisi histolojisi

Etiket: Karaciğer biyopsisi histolojisi | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Sinüzoid lümenine komşu yerleşimli, fagositik özellikte makrofaj hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Karaciğerin yerleşik makrofajlarını düşündürür. | Sonuç yorumu: Karaciğerin yerleşik makrofajlarını düşündürür. | Sonuç başlığı: Karaciğer biyopsisi histolojisi | Sonuç özeti: Sinüzoid lümenine komşu yerleşimli, fagositik özellikte makrofaj hücreleri izlendi. | Yorum: Karaciğerin yerleşik makrofajlarını düşündürür. | Satırlar: Karaciğer biyopsisi histolojisi / Sinüzoid lümenine komşu yerleşimli, fagositik özellikte makrofaj hücreleri izlendi. / Karaciğerin yerleşik makrofajlarını düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-132 | Başlık: Karaciğer biyopsisi histolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Sinüzoid lümenine komşu yerleşimli, fagositik özellikte makrofaj hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Karaciğerin yerleşik makrofajlarını düşündürür. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/132_kupffer_hucresti_karaciger_histoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/132_kupffer_hucresti_karaciger_histoloji.webp | Alt text: Karaciğer biyopsisi histolojisi - Sinüzoid lümenine komşu yerleşimli, fagositik özellikte makrofaj hücreleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hücreler aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kupffer hücresi
B) Ito hücresi
C) Hepatosit
D) Kolanjiyosit
E) Tip II pnömosit

Doğru Cevap: Kupffer hücresi

A) Kupffer hücresi: Kupffer hücresi karaciğer sinüzoidlerinde bulunan fagositik makrofajdır ve biyopsi bulgusunu açıklar. Vakadaki “Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.” ve “Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Ito hücresi: Ito hücresi Disse aralığında vitamin A depolar ve fibroziste kollajen üretimiyle ilişkilidir; primer fagositik hücre değildir. Bu olguda “Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.” ve “Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kupffer hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Hepatosit: Hepatosit karaciğer parankim hücresidir ve metabolik-sentetik işlevler üstlenir; sinüzoidal makrofaj değildir. Bu olguda “Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.” ve “Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kupffer hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Kolanjiyosit: Kolanjiyosit safra kanallarını döşeyen epitel hücresidir; sinüzoid lümenindeki fagositik hücre değildir. Bu olguda “Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.” ve “Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kupffer hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Tip II pnömosit: Tip II pnömosit alveolde surfaktan üretir; karaciğer sinüzoid histolojisiyle ilişkili değildir. Bu olguda “Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.” ve “Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Kupffer hücresi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Karaciğerde fagositik hücre olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.” ve “Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.” birlikte okunduğunda Kupffer hücresi seçeneği öne çıkar; “Soru karaciğerin yerleşik makrofajını sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kupffer hücreleri karaciğer sinüzoidlerinde yerleşen doku makrofajlarıdır. Portal dolaşımdan gelen partikül, bakteri ve yaşlı eritrosit kalıntılarını fagosite ederek retikuloendotelial işlev görürler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.”, “Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.” ve “Soru karaciğerin yerleşik makrofajını sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kupffer hücresi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hücreler karaciğer sinüzoidleriyle ilişkili olarak tanımlanmıştır.

Kanıt 2: Biyopside fagositik özellik vurgulanmıştır.

Kanıt 3: Soru karaciğerin yerleşik makrofajını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Kupffer hücreleri karaciğer sinüzoidlerinin makrofajlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 261: v188-new-261-yenidoganda-siyanoz-ve-tek-buyuk-damar-cikisi

Başlık: Yenidoğanda siyanoz ve tek büyük damar çıkışı

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Aortopulmoner septum gelişim kusurunu persistan trunkus arteriozus ile ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan sonra devam eden siyanoz ve üfürüm nedeniyle inceleniyor. Miadında doğduğu, oksijen desteğine rağmen siyanozunun tam düzelmediği öğreniliyor. Prenatal takipleri düzensizdir.

Demografi: 2 günlük erkek yenidoğan | Setting: yenidoğan kardiyoloji biriminde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 148/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %82% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,11 (yüksek)

Fizik Muayene

- Santral siyanoz vardır.
- Sternum sol kenarında sistolik üfürüm duyulur.
- Femoral nabızlar alınmaktadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Tek büyük arteriyel trunkustan sistemik, pulmoner ve koroner dolaşımın çıktığı ve ventriküler septal defekt eşlik ettiği izlendi. | Klinik anlam: Persistan trunkus arteriozus ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Persistan trunkus arteriozus ile uyumludur. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Tek büyük arteriyel trunkustan sistemik, pulmoner ve koroner dolaşımın çıktığı ve ventriküler septal defekt eşlik ettiği izlendi. | Yorum: Persistan trunkus arteriozus ile uyumludur. | Satırlar: Ekokardiyografi / Tek büyük arteriyel trunkustan sistemik, pulmoner ve koroner dolaşımın çıktığı ve ventriküler septal defekt eşlik ettiği izlendi. // Persistan trunkus arteriozus ile uyumludur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-133 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Tek büyük arteriyel trunkustan sistemik, pulmoner ve koroner dolaşımın çıktığı ve ventriküler septal defekt eşlik ettiği izlendi. | Klinik anlam: Persistan trunkus arteriozus ile uyumludur. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/133_persistan_trunkus_arteriozus_eko.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/133_persistan_trunkus_arteriozus_eko.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Tek büyük arteriyel trunkustan sistemik, pulmoner ve koroner dolaşımın çıktığı ve ventriküler septal defekt eşlik ettiği izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu anomalinin temel embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aortopulmoner septumun oluşmaması
B) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu
C) Ductus venosusun açık kalması
D) Omfalomezenterik kanalın persiste kalması
E) Ürakuşun kapanmaması

Doğru Cevap: Aortopulmoner septumun oluşmaması

- A) Aortopulmoner septumun oluşmaması: Aortopulmoner septumun oluşmaması tek arteriyel trunkus ve eşlik eden ventriküler septal defektli açıklar. Vakadaki “Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.” ve “Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu: Septum primumun aşırı rezorpsiyonu atriyal septal defekt mekanizmasıdır; tek arteriyel trunkus oluşturmaz. Bu olguda “Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.” ve “Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Aortopulmoner septumun oluşmaması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ductus venosusun açık kalması: Ductus venosusun açık kalması fetal venöz dolaşım kalıntısıyla ilişkilidir; konotrunkal ayrışma kusuru değildir. Bu olguda “Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.” ve “Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Aortopulmoner septumun oluşmaması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Omfalomezenterik kanalın persiste kalması: Omfalomezenterik kanalın persiste kalması Meckel divertikülüne yol açar; büyük damar çıkış anomalisi yapmaz. Bu olguda “Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.” ve “Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Aortopulmoner septumun oluşmaması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Ürakuşun kapanmaması: Ürakuşun kapanmaması umbilikal idrar kaçağına neden olabilir; aortopulmoner septasyonla ilişkili değildir. Bu olguda “Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.” ve “Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Aortopulmoner septumun oluşmaması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda siyanoz ve tek büyük damar çıkışı olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur.

“Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.” ve “Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.” birlikte okunduğunda Aortopulmoner septumun oluşmaması seçeneği öne çıkar; “Ventriküler septal defekt eşlik etmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Persistan trunkus arteriozus, konotrunkal bölgenin aort ve pulmoner arter olarak ayrışmaması sonucu oluşur. Temel sorun nöral krest katkılı aortopulmoner septumun gelişmemesi veya spiral septasyon kusurudur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.”, “Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.” ve “Ventriküler septal defekt eşlik etmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Aortopulmoner septumun oluşmaması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Yenidoğanda oksijenle tam düzelmeyen siyanoz vardır.

Kanıt 2: Ekokardiyografide tek büyük arteriyel trunkus gösterilmiştir.

Kanıt 3: Ventriküler septal defekt eşlik etmektedir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Konotrunkal anomaliler nöral krest hücreleri ve aortopulmoner septasyon kusurlarıyla ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 262: v188-new-262-oksidatif-stres-ve-eritrosit-korunmasi

Başlık: Oksidatif stres ve eritrosit korunması

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Glutasyon sisteminde NADPH'nin antioksidan savunmadaki rolünü açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hastada oksidatif ilaç maruziyeti sonrası eritrositlerin antioksidan savunma kapasitesi tartışılıyor. Daha önce oksidatif stres yapan ilaçlardan sonra sarılık ve koyu idrar geliştiği öğreniliyor. Değerlendirme eritrosit metabolizması mekanizmasına yöneliktir.

Demografi: 21 yaşında erkek hasta | Setting: biyokimya laboratuvarı değerlendirmesinde inceleniyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Muayenede aktif hemoliz bulgusu yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Eritrosit enzim değerlendirmesi

Etiket: Eritrosit enzim değerlendirmesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: NADPH üretim kapasitesinin azaldığı gösterildi. | Klinik anlam: Antioksidan savunma bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Antioksidan savunma bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Eritrosit enzim değerlendirmesi | Sonuç özeti: NADPH üretim kapasitesinin azaldığı gösterildi. | Yorum: Antioksidan savunma bozukluğunu destekler. | Satırlar: Eritrosit enzim değerlendirmesi / NADPH üretim kapasitesinin azaldığı gösterildi. // Antioksidan savunma bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: NADPH eritrositte oksidatif strese karşı korumayı en çok hangi mekanizmayla sağlar?

- A) İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak
- B) Hemoglobini oksijene irreversibl bağlayarak
- C) DNA replikasyonunu tamamen durdurarak
- D) Laktat üretimini engelleyerek
- E) Sodyum kanallarını bloke ederek

Doğru Cevap: İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak

A) İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak: İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlamak NADPH'nin eritrositteki temel antioksidan işlevidir. Vakadaki "Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır." ve "NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Hemoglobini oksijene irreversibl bağlayarak: Hemoglobinin oksijeni irreversibl bağlaması fizyolojik değildir ve antioksidan koruma sağlamaz. Bu olguda "Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır." ve "NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini seçeneğini daha güçlü kılar.

C) DNA replikasyonunu tamamen durdurarak: Eritrositlerde çekirdek bulunmadığı için DNA replikasyonunun durdurulması bu mekanizmayı açıklamaz. Bu olguda "Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır." ve "NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Laktat üretimini engelleyerek: Laktat üretimini engellemek eritrosit enerji metabolizmasını bozabilir ve oksidatif savunmanın temel mekanizması değildir. Bu olguda "Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır." ve "NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Sodyum kanallarını bloke ederek: Vakadaki Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır ve NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir. Bu olguda "Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır." ve "NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Oksidatif stres ve eritrosit korunması olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır." ve "NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir." birlikte okunduğunda İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak seçeneği öne çıkar; "Hastada oksidatif ilaçlarla hemoliz öyküsü vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: NADPH, glutatyon redüktaz aracılığıyla okside glutatyonu indirgenmiş glutatyon formuna çevirir. İndirgenmiş glutatyon peroksidleri detoksifiye ederek eritrositleri oksidatif hasardan korur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır.", "NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir." ve "Hastada oksidatif ilaçlarla hemoliz öyküsü vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İndirgenmiş glutatyonun yenilenmesini sağlayarak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Soruda eritrosit oksidatif stres yanıtı sorgulanmaktadır.

Kanıt 2: NADPH üretim kapasitesinin azaldığı belirtilmiştir.

Kanıt 3: Hastada oksidatif ilaçlarla hemoliz öyküsü vardır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: NADPH, glutatyonu indirgenmiş halde tutarak eritrositi oksidatif stresten korur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 263: v188-new-263-erkek-bebekte-hiperammonemi

Başlık: Erkek bebekte hiperammonemi

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Üre döngüsü bozukluğunda hiperammonemiyi orotik asit artışıyla ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, emmede azalma, kusma, letarji ve solunum düzensizliği nedeniyle yatırılıyor. Doğumdan sonra ilk gün iyi olduğu, proteinli beslenme arttıkça uykuya eğilim ve kusmanın geliştiği öğreniliyor. Ailede erkek bebek ölüm öyküsü vardır.

Demografi: 5 günlük erkek yenidoğan | Setting: metabolizma yoğun bakımında değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 164/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,34 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve hipotoniktir.
- Karaciğer belirgin büyük değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma amonyak

Etiket: Plazma amonyak | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ciddi hiperammonemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Ciddi hiperammonemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Plazma amonyak | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Ciddi hiperammonemiyi gösterir. | Satırlar: Plazma amonyak / Belirgin yüksek saptandı. / 720 µmol/L / <80 µmol/L yenidoğan için

Tetkik 2: İdrar orotik asit

Etiket: İdrar orotik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ornitin transkarbamilaz eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: Ornitin transkarbamilaz eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: İdrar orotik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Ornitin transkarbamilaz eksikliğini destekler. | Satırlar: İdrar orotik asit / Yüksek saptandı. / Ornitin transkarbamilaz eksikliğini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası enzim defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ornitin transkarbamilaz eksikliği
B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
C) Homogentizat oksidaz eksikliği
D) Glukoz-6-fosfataz eksikliği
E) Galaktokinaz eksikliği

Doğru Cevap: Ornitin transkarbamilaz eksikliği

A) Ornitin transkarbamilaz eksikliği: Ornitin transkarbamilaz eksikliği erkek yenidoğanda ağır hiperammonemi ve orotik asit artışıyla en uyumlu defektir. Vakadaki "Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır." ve "Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleşenir.

B) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüri yapar; akut hiperammonemi ve orotik asit artışı beklenmez. Bu olguda "Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır." ve "Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Homogentizat oksidaz eksikliği: Vakadaki Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır ve Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda "Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır." ve "Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Glukoz-6-fosfataz eksikliği: Glukoz-6-fosfataz eksikliği açlık hipoglisemisi ve hepatomegali yapar; orotik asit artışı hiperammonemi açıklamaz. Bu olguda "Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır." ve "Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Galaktokinaz eksikliği: Vakadaki Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır ve Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda "Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır." ve "Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erkek bebekte hiperammonemi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır." ve "Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir." birlikte okunduğunda Ornitin transkarbamilaz eksikliği seçeneği öne çıkar; "İdrar orotik asit düzeyi artmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğan erkek bebekte protein alımı sonrası ağır hiperammonemi, letarji ve idrar orotik asit artışı ornitin transkarbamilaz eksikliğini düşündürür. Karbamoil fosfat mitokondriden sitozole yönlenerak pirimidin sentezini artırır ve orotik asit yükselir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır.", "Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir." ve "İdrar orotik asit düzeyi artmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ornitin transkarbamilaz eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme arttıkça başlamıştır.

Kanıt 2: Plazma amonyak düzeyi belirgin yüksektir.

Kanıt 3: İdrar orotik asit düzeyi artmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: OTC eksikliğinde hiperammonemiye orotik asit artışı eşlik eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 264: v188-new-264-ates-ve-petesiyal-dokuntu

Başlık: Ateş ve peteşiyal döküntü

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla ilişkilendirme.

Learning Target: Neisseria meningitidis enfeksiyonunu peteşi, sepsis ve kapsüllü diplokok yapısıyla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yüksek ateş, baş ağrısı, ense sertliği ve yaygın peteşiyal döküntü nedeniyle başvuruyor. Yurtta kaldığı, son 12 saatte hızla kötüleştiği ve kusma geliştiği öğreniliyor. Aşı öyküsü net değildir.

Demografi: 19 yaşında erkek öğrenci | Setting: acil serviste değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/48 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 39.4°C | Şok indeksi: 1,53 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta toksik görünümündedir.
- Ense sertliği vardır.
- Alt ekstremitelerde yaygın peteşiyal döküntüler izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama

Etiket: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar izlendi. | Klinik anlam: Meningokok enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Meningokok enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Sonuç özeti: Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar izlendi. | Yorum: Meningokok enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama / Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar izlendi. // Meningokok enfeksiyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-134 | Başlık: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama | Modalite: microscopy | Bulgu: Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar izlendi. | Klinik anlam: Meningokok enfeksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqds.public.blob.vercel-storage.com/134_meningokok_bos_gram_boyama.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqds.public.blob.vercel-storage.com/134_meningokok_bos_gram_boyama.webp | Alt text: Beyin omurilik sıvısı Gram boyama - Nötrofiller içinde gram-negatif diplokoklar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Neisseria meningitidis
B) Streptococcus pneumoniae
C) Listeria monocytogenes
D) Haemophilus influenzae tip b
E) Cryptococcus neoformans

Doğru Cevap: Neisseria meningitidis

A) Neisseria meningitidis: Neisseria meningitidis gram-negatif diplokok yapısı, peteşiyal döküntü ve hızlı sepsis-menenjit tablosuyla en uyumlu etkindir. Vakadaki “Hasta yurtta kalan genç erişkindir.” ve “Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Streptococcus pneumoniae: Streptococcus pneumoniae gram-pozitif diplokoktur ve peteşiyal purpura meningokok kadar tipik değildir. Bu olguda “Hasta yurtta kalan genç erişkindir.” ve “Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Listeria monocytogenes: Listeria monocytogenes gram-pozitif basil olup yenidoğan, yaşlı ve immünsüpre hastalarda menenjit yapar. Bu olguda “Hasta yurtta kalan genç erişkindir.” ve “Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Haemophilus influenzae tip b: Haemophilus influenzae tip b gram-negatif kokobasildir; gram-negatif diplokok paternini açıklamaz. Bu olguda “Hasta yurtta kalan genç erişkindir.” ve “Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Cryptococcus neoformans: Cryptococcus neoformans kapsüllü maya olup özellikle immünsüpre hastalarda subakut menenjit yapar. Bu olguda “Hasta yurtta kalan genç erişkindir.” ve “Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Neisseria meningitidis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve peteşiyal döküntü olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hasta yurtta kalan genç erişkindir.” ve “Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.” birlikte okunduğunda Neisseria meningitidis seçeneği öne çıkar; “Beyin omurilik sıvısında gram-negatif diplokoklar izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Genç erişkinde hızlı seyirli menenjit, peteşiyal döküntü, şok ve beyin omurilik sıvısında nötrofiller içinde gram-negatif diplokok görülmesi Neisseria meningitidis enfeksiyonunu düşündürür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta yurtta kalan genç erişkindir.”, “Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.” ve “Beyin omurilik sıvısında gram-negatif diplokoklar izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Neisseria meningitidis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta yurtta kalan genç erişkindir.

Kanıt 2: Menenjit bulgularına peteşiyal döküntü ve şok eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Beyin omurilik sıvısında gram-negatif diplokoklar izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Meningokok menenjiti peteşi-purpura ve hızlı sepsis tablosuyla klasik olarak ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 265: v188-new-265-yanik-yarasinda-kotu-kokulu-akinti

Başlık: Yanık yarasında kötü kokulu akıntı

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla ilişkilendirme.

Learning Target: Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonunu yanık zemini, mavi-yeşil pigment ve oksidaz pozitiflikle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yanık alanında kötü kokulu mavi-yeşil akıntı ve ateş gelişmesi nedeniyle inceleniyor. Bir hafta önce sıcak sıvı yanığı nedeniyle yatırıldığı, son 24 saatte ateşinin yükseldiği ve pansumanlarda renkli akıntı fark edildiği öğreniliyor.

Demografi: 36 yaşında erkek hasta | Setting: yanık ünitesinde enfeksiyon açısından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.8°C | Şok indeksi: 1,00 (yüksek)

Fizik Muayene

- Yanık alanında nemli, kötü kokulu, mavi-yeşil pigmentli akıntı vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yara kültürü

Etiket: Yara kültürü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Oksidaz pozitif, nonfermentatif gram-negatif basil üredi. | Klinik anlam: Pseudomonas enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Pseudomonas enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Yara kültürü | Sonuç özeti: Oksidaz pozitif, nonfermentatif gram-negatif basil üredi. | Yorum: Pseudomonas enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Yara kültürü / Oksidaz pozitif, nonfermentatif gram-negatif basil üredi. / / Pseudomonas enfeksiyonunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu enfeksiyonun en olası etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pseudomonas aeruginosa
- B) Staphylococcus aureus
- C) Streptococcus pyogenes
- D) Clostridium perfringens
- E) Escherichia coli

Doğru Cevap: Pseudomonas aeruginosa

A) Pseudomonas aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa yanık zemininde mavi-yeşil pigmentli akıntı ve oksidaz pozitif nonfermentatif gram-negatif basil bulgusuyla en uyumludur. Vakadaki "Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir." ve "Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Staphylococcus aureus: Staphylococcus aureus gram-pozitif koktur ve mavi-yeşil pigmentli oksidaz pozitif nonfermentatif basil değildir. Bu olguda "Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir." ve "Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur." ipuçları tanısız karar açısından Pseudomonas aeruginosa seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Streptococcus pyogenes: Streptococcus pyogenes gram-pozitif zincir yapan koktur; kültür ve pigment bulgusu uyumlu değildir. Bu olguda "Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir." ve "Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur." ipuçları tanısız karar açısından Pseudomonas aeruginosa seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Clostridium perfringens: Clostridium perfringens anaerob gram-pozitif basil olup gazlı gangrenle ilişkilidir; mavi-yeşil pigment tipik değildir. Bu olguda "Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir." ve "Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur." ipuçları tanısız karar açısından Pseudomonas aeruginosa seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Escherichia coli: Escherichia coli fermentatif gram-negatif basildir; oksidaz pozitif nonfermentatif patern Pseudomonas lehinedir. Bu olguda "Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir." ve "Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur." ipuçları tanısız karar açısından Pseudomonas aeruginosa seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yanık yarasında kötü kokulu akıntı olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir." ve "Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur." birlikte okunduğunda Pseudomonas aeruginosa seçeneği öne çıkar; "Kültürde oksidaz pozitif nonfermentatif gram-negatif basil üremiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yanık yarasında mavi-yeşil pigmentli kötü kokulu akıntı ve oksidaz pozitif nonfermentatif gram-negatif basil üremesi Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonunu düşündürür. Bu etken yanık ve hastane ilişkili enfeksiyonlarda önemlidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir.", "Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur." ve "Kültürde oksidaz pozitif nonfermentatif gram-negatif basil üremiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pseudomonas aeruginosa en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Enfeksiyon yanık yarası zemininde gelişmiştir.

Kanıt 2: Akıntı mavi-yeşil pigmentli ve kötü kokuludur.

Kanıt 3: Kültürde oksidaz pozitif nonfermentatif gram-negatif basil üremiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Pseudomonas aeruginosa yanık yaralarında mavi-yeşil pigment ve üzüm benzeri koku ile ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 266: v188-new-266-gogus-agrisi-sonrasi-miyokard-hasari

Başlık: Göğüs ağrısı sonrası miyokard hasarı

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik paterni klinik tabloyla ilişkilendirme.

Learning Target: Akut miyokard enfarktüsünde koagülasyon nekrozunu histopatolojik patern olarak tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, uzun süren baskı tarzı göğüs ağrısı sonrası miyokard enfarktüsü tanısıyla yatırılıyor. Ağrının 3 saatten uzun sürdüğü, sol kola yayıldığı ve terleme ile bulantının eşlik ettiği öğreniliyor. Sigara ve hipertansiyon öyküsü vardır.

Demografi: 61 yaşında erkek hasta | Setting: kardiyoloji servisinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 148/92 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,70

Fizik Muayene

- Hasta ağırlı ve terli görünmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Troponin I

Etiket: Troponin I | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Miyokard nekrozunu destekler. | Sonuç yorumu: Miyokard nekrozunu destekler. | Sonuç başlığı: Troponin I | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Miyokard nekrozunu destekler. | Satırlar: Troponin I / Yüksek saptandı. / 8.2 ng/mL / <0.04 ng/mL

Tetkik 2: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünü destekler. | Sonuç yorumu: ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünü destekler. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Yorum: ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünü destekler. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. // ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünü destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-135 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Klinik anlam: ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünü destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/135_anterior_stemi_ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/135_anterior_stemi_ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Anterior derivasyonlarda ST elevasyonu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu iskemi tipinde miyokardda beklenen temel nekroz paterni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Koagülasyon nekrozu
- B) Likefaksiyon nekrozu
- C) Kazeifikasyon nekrozu
- D) Yağ nekrozu
- E) Fibrinoid nekroz

Doğru Cevap: Koagülasyon nekrozu

- A) Koagülasyon nekrozu: Koagülasyon nekrozu miyokard enfarktüsünde beklenen temel iskemik nekroz paternidir. Vakadaki “Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.” ve “Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Likefaksiyon nekrozu: Likefaksiyon nekrozu beyin enfarktleri ve apselerde tipiktir; miyokard iskemisinin klasik paterni değildir. Bu olguda “Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.” ve “Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Kazeifikasyon nekrozu: Vakadaki Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır ve Troponin I düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda “Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.” ve “Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Yağ nekrozu: Vakadaki Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır ve Troponin I düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda “Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.” ve “Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Fibrinoid nekroz: Fibrinoid nekroz immün damar hasarı ve malign hipertansiyon gibi vasküler patolojilerde görülür. Bu olguda “Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.” ve “Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.” ipuçları klinik karar açısından Koagülasyon nekrozu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Göğüs ağrısı sonrası miyokard hasarı olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.” ve “Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.” birlikte okunduğunda Koagülasyon nekrozu seçeneği öne çıkar; “Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Miyokard enfarktüsünde iskemik hücre ölümü tipik olarak koagülasyon nekrozudur. Doku mimarisi başlangıçta korunur, daha sonra nötrofil infiltrasyonu ve onarım süreci gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.”, “Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.” ve “Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Koagülasyon nekrozu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada uzun süren iskemik göğüs ağrısı vardır.

Kanıt 2: Troponin I düzeyi belirgin yüksektir.

Kanıt 3: Elektrokardiyografide ST elevasyonu izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Kalp, böbrek ve dalak gibi solid organ iskemilerinde tipik nekroz paterni koagülasyon nekrozudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 267: v188-new-267-antikoagulan-kullanırken-ciddi-kanama

Başlık: Antikoagulan kullanırken ciddi kanama

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Varfarin toksisitesinde INR yüksekliği ve kanama varlığında vitamin K ile protrombin kompleks konsantresi yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, varfarin kullanımı sırasında melena, halsizlik ve baş dönmesi nedeniyle başvuruyor. Atriyal fibrilasyon nedeniyle varfarin kullandığı, son günlerde antibiyotik başladığı ve düzenli INR kontrolü yaptırmadığı öğreniliyor. İki gündür siyah dışkılama tariflemektedir.

Demografi: 69 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,41 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve halsizdir.
- Rektal muayenede melena izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: INR

Etiket: INR | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aşırı antikoagülasyonu gösterir. | Sonuç yorumu: Aşırı antikoagülasyonu gösterir. | Sonuç başlığı: INR | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Aşırı antikoagülasyonu gösterir. | Satırlar: INR / Belirgin yüksek saptandı. / 8.6 / Genellikle tedavi hedefi 2-3

Tetkik 2: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Ciddi kanamayı destekler. | Sonuç yorumu: Ciddi kanamayı destekler. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Ciddi kanamayı destekler. | Satırlar: Hemoglobin / Düşük saptandı. / 7.4 g/dL / 13.5-17.5 g/dL

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil geri çevirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi
B) Protamin sülfat verilmesi
C) Flumazenil verilmesi
D) Nalokson verilmesi
E) Asetilsistein verilmesi

Doğru Cevap: Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi

A) Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi: Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi ciddi varfarin ilişkili kanamada hem hızlı hem kalıcı geri çevirme için uygundur. Vakadaki “Hasta varfarin kullanmaktadır.” ve “Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Protamin sülfat verilmesi: Vakadaki Hasta varfarin kullanmaktadır ve Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir. Bu olguda “Hasta varfarin kullanmaktadır.” ve “Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Flumazenil verilmesi: Vakadaki Hasta varfarin kullanmaktadır ve Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir. Bu olguda “Hasta varfarin kullanmaktadır.” ve “Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nalokson verilmesi: Vakadaki Hasta varfarin kullanmaktadır ve Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir. Bu olguda “Hasta varfarin kullanmaktadır.” ve “Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Asetilsistein verilmesi: Asetilsistein parasetamol toksisitesinde kullanılır; INR yüksekliği ve kanama kontrolü sağlamaz. Bu olguda “Hasta varfarin kullanmaktadır.” ve “Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antikoagulan kullanırken ciddi kanama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta varfarin kullanmaktadır.” ve “Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.” birlikte okunduğunda Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi seçeneği öne çıkar; “INR belirgin yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Varfarin vitamin K epoksit redüktazı inhibe eder ve K vitaminine bağımlı faktörlerin azalmasına yol açar. Ciddi kanama ve çok yüksek INR varlığında hızlı faktör replasmanı için protrombin kompleks konsantresi ve sürdürülebilir geri dönüş için vitamin K verilmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta varfarin kullanmaktadır.”, “Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.” ve “INR belirgin yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Vitamin K ve protrombin kompleks konsantresi verilmesi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hasta varfarin kullanmaktadır.

Kanıt 2: Melena, hipotansiyon ve hemoglobin düşüklüğü ciddi kanamayı gösterir.

Kanıt 3: INR belirgin yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ciddi varfarin kanamasında vitamin K tek başına yavaş kalır; protrombin kompleks konsantresi hızlı geri çevirme sağlar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 268: v188-new-268-epigastrik-agri-ve-lipaz-yuksekligi

Başlık: Epigastrik ağrı ve lipaz yüksekliği

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Akut pankreatitte ilk tedavi basamaklarını ve gereksiz erken antibiyotiği ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sırtta yayılan şiddetli epigastrik ağrı, bulantı ve kusma nedeniyle başvuruyor. Ağrının ağır alkol alımı sonrası başladığı, öne eğilmekle kısmen azaldığı öğreniliyor. Ateş veya sarılık tariflememektedir.

Demografi: 45 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste genel cerrahi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/66 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,08 (yüksek)

Fizik Muayene

- Epigastrik bölgede belirgin hassasiyet vardır.
- Yaygın peritonit bulgusu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum lipaz

Etiket: Serum lipaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut pankreatiti destekler. | Sonuç yorumu: Akut pankreatiti destekler. | Sonuç başlığı: Serum lipaz | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Akut pankreatiti destekler. | Satırlar: Serum lipaz / Belirgin yüksek saptandı. / 920 U/L / 13-60 U/L

Tetkik 2: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Safra yollarında belirgin dilatasyon izlenmedi. | Klinik anlam: Obstrüktif biliyer neden ön planda değildir. | Sonuç yorumu: Obstrüktif biliyer neden ön planda değildir. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Safra yollarında belirgin dilatasyon izlenmedi. | Yorum: Obstrüktif biliyer neden ön planda değildir. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Safra yollarında belirgin dilatasyon izlenmedi. // Obstrüktif biliyer neden ön planda değildir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-136 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Safra yollarında belirgin dilatasyon izlenmedi. | Klinik anlam: Obstrüktif biliyer neden ön planda değildir. | URL: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/136_normal_safra_yollari_ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/136_normal_safra_yollari_ultrasonografi.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Safra yollarında belirgin dilatasyon izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem
- B) Rutin erken profilaktik antibiyotik başlanması
- C) Acil pankreatektomi yapılması
- D) Oral antiasit tedavisiyle ayaktan izlem
- E) Laksatif tedavi başlanması

Doğru Cevap: İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem

- A) İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem: İntravenöz sıvı, analjezi ve yakın izlem akut pankreatitin uygun başlangıç tedavisidir. Vakadaki "Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir." ve "Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Rutin erken profilaktik antibiyotik başlanması: Rutin erken profilaktik antibiyotik enfekte nekroz kanıtı olmayan akut pankreatitte gerekli değildir. Bu olguda "Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir." ve "Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Acil pankreatektomi yapılması: Vakadaki Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir ve Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir. Bu olguda "Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir." ve "Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Oral antiasit tedavisiyle ayaktan izlem: Vakadaki Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir ve Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir. Bu olguda "Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir." ve "Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Laksatif tedavi başlanması: Vakadaki Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir ve Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir. Bu olguda "Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir." ve "Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Epigastrik ağrı ve lipaz yüksekliği olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir." ve "Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir." birlikte okunduğunda İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem seçeneği öne çıkar; "Enfekte nekroz veya kolanjit bulgusu verilmemiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Akut pankreatitte başlangıç tedavisi destekleyicidir; erken dönemde yeterli intravenöz sıvı resüsitasyonu, analjezi, bulantı kontrolü ve beslenme planı yapılır. Enfekte nekroz kanıtı olmadan rutin profilaktik antibiyotik önerilmez. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir.", "Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir." ve "Enfekte nekroz veya kolanjit bulgusu verilmemiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz sıvı, analjezi, oral alımın düzenlenmesi ve yakın klinik izlem en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Epigastrik ağrı sırta yayılmakta ve lipaz belirgin yüksektir.

Kanıt 2: Ağır alkol alımı atağı tetiklemiştir.

Kanıt 3: Enfekte nekroz veya kolanjit bulgusu verilmemiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Akut pankreatitte ilk tedavi destek tedavisidir; antibiyotik enfekte nekroz veya kolanjit gibi durumlarda düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 269: v188-new-269-dogum-sonrasi-yogun-kanama

Başlık: Doğum sonrası yoğun kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Postpartum uterin atonide ilk basamak uterotonik tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, plasenta ayrıldıktan sonra yoğun vajinal kanama gelişmesi nedeniyle izleniyor. Doğumun uzamış eylem sonrası gerçekleştiği ve bebeğin iri olduğu öğreniliyor. Plasentanın tam çıktığı belirtilmektedir.

Demografi: 30 yaşında kadın hasta | Setting: vajinal doğum sonrası doğumhanede değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,26 (yüksek)

Fizik Muayene

- Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.
- Vajinal kanama parlak kırmızı ve fazladır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk uygulanması gereken yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uterin masaj ve oksitosin uygulanması
B) Metotreksat verilmesi
C) Dijital servikal dilatasyon yapılması
D) Oral demir tedavisiyle ayaktan izlem
E) Magnezyum sülfat başlanması

Doğru Cevap: Uterin masaj ve oksitosin uygulanması

A) Uterin masaj ve oksitosin uygulanması: Uterin masaj ve oksitosin uterin atoniye bağlı postpartum kanamada ilk basamak tedavidir. Vakadaki “Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.” ve “Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Metotreksat verilmesi: Vakadaki Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır ve Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir. Bu olguda “Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.” ve “Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve oksitosin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Dijital servikal dilatasyon yapılması: Vakadaki Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır ve Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir. Bu olguda “Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.” ve “Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve oksitosin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral demir tedavisiyle ayaktan izlem: Vakadaki Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır ve Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir. Bu olguda “Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.” ve “Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve oksitosin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Magnezyum sülfat başlanması: Magnezyum sülfat eklampsi nöbet profilaksisinde kullanılır; uterin atoni kanamasının ilk tedavisi değildir. Bu olguda “Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.” ve “Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uterin masaj ve oksitosin uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Doğum sonrası yoğun kanama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.” ve “Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.” birlikte okunduğunda Uterin masaj ve oksitosin uygulanması seçeneği öne çıkar; “Uzamış doğum ve iri bebek uterin atoni riskini artırmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Doğum sonrası yoğun kanama ve yumuşak-gevşek uterus uterin atoniye bağlı postpartum kanamayı düşündürür. İlk yaklaşım uterin masaj, oksitosin ve eş zamanlı hemodinamik destekle uterin kontraksiyonu sağlamaktır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.”, “Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.” ve “Uzamış doğum ve iri bebek uterin atoni riskini artırmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Uterin masaj ve oksitosin uygulanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanama plasenta ayrıldıktan sonra doğum sonrası dönemde başlamıştır.

Kanıt 2: Uterus palpasyonda yumuşak ve gevşektir.

Kanıt 3: Uzamış doğum ve iri bebek uterin atoni riskini artırmaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Postpartum kanamanın en sık nedeni uterin atonidir; ilk yaklaşım uterin masaj ve oksitosindir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 270: v188-new-270-goz-cevresinde-sislik-ve-agri

Başlık: Göz çevresinde şişlik ve ağrı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Akut bakteriyel orbital selülitte proptoz ve göz hareket kısıtlılığıyla acil intravenöz antibiyotik gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, ateş, göz çevresinde şişlik ve göz hareketleriyle ağrı nedeniyle getiriliyor. Son bir haftadır sinüzit bulguları olduğu, son iki günde sağ göz çevresinde hızla artan şişlik ve ateş geliştiği öğreniliyor. Görmesinin bulanıklaştığını söylemektedir.

Demografi: 8 yaşında erkek çocuk | Setting: acil serviste göz hastalıkları ve kulak burun boğaz tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.9°C | Şok indeksi: 1,22 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ gözde belirgin periorbital ödem, proptoz ve konjonktival kemozis vardır.
- Göz hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Orbita bilgisayarlı tomografi

Etiket: Orbita bilgisayarlı tomografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ orbitada postseptal inflamasyon ve etmoid sinüzit bulguları izlendi. | Klinik anlam: Orbital selülit destekler. | Sonuç yorumu: Orbital selülit destekler. | Sonuç başlığı: Orbita bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Sağ orbitada postseptal inflamasyon ve etmoid sinüzit bulguları izlendi. | Yorum: Orbital selülit destekler. | Satırlar: Orbita bilgisayarlı tomografi | Sağ orbitada postseptal inflamasyon ve etmoid sinüzit bulguları izlendi. // Orbital selülit destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-137 | Başlık: Orbita bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Sağ orbitada postseptal inflamasyon ve etmoid sinüzit bulguları izlendi. | Klinik anlam: Orbital selülit destekler. | URL: https://iukbtikzxicqdsd.public.blob.vercel-storage.com/137_orbital_selulit_bt.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxicqdsd.public.blob.vercel-storage.com/137_orbital_selulit_bt.webp | Alt text: Orbita bilgisayarlı tomografi - Sağ orbitada postseptal inflamasyon ve etmoid sinüzit bulguları izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi
- B) Oral antihistaminik verilmesi
- C) Soğuk kompres ve ayaktan yakın kontrol önermek
- D) Yüksek doz oral antibiyotik ile 24-48 saat poliklinik izlemi planlamak
- E) Topikal antibiyotikli damla kullanılması

Doğru Cevap: Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi

- A) Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi: Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik ve yakın izlem orbital selülitte doğru tedavi yaklaşımıdır. Vakadaki “Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.” ve “Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Oral antihistaminik verilmesi: Vakadaki Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir ve Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır. Bu olguda “Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.” ve “Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Soğuk kompres ve ayaktan yakın kontrol önermek: Vakadaki Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir ve Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır. Bu olguda “Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.” ve “Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Yüksek doz oral antibiyotik ile 24-48 saat poliklinik izlemi planlamak: Vakadaki Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir ve Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır. Bu olguda “Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.” ve “Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Topikal antibiyotikli damla kullanılması: Vakadaki Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir ve Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır. Bu olguda “Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.” ve “Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Göz çevresinde şişlik ve ağrı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.” ve “Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.” birlikte okunduğunda Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi seçeneği öne çıkar; “BT’de postseptal orbital inflamasyon gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sinüzit sonrası ateş, proptoz, göz hareket kısıtlılığı, kemozis ve postseptal inflamasyon orbital selülit düşündürür. Görmeyi ve intrakraniyal yayılımı tehdit eden bu tabloda hastaneye yatış, intravenöz antibiyotik ve multidisipliner izlem gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.”, “Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.” ve “BT’de postseptal orbital inflamasyon gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hastaneye yatırılarak intravenöz geniş spektrumlu antibiyotik başlanması ve yakın göz-KBB izlemi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakınmalar sinüzit bulgularını takiben gelişmiştir.

Kanıt 2: Proptoz ve göz hareket kısıtlılığı vardır.

Kanıt 3: BT’de postseptal orbital inflamasyon gösterilmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Orbital selülitte proptoz ve göz hareket kısıtlılığı preseptal selülitte ayırıcı ciddi bulgulardır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 271: v189-new-271-kalca-enjeksiyonu-sonrasi-yurume-bozuklugu

Başlık: Kalça enjeksiyonu sonrası yürüme bozukluğu

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulguyla ilişkilendirme.

Learning Target: Nervus gluteus superior hasarını Trendelenburg bulgusuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kalça bölgesine yapılan enjeksiyon sonrası gelişen topallama ve merdiven çıkmada zorlanma nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık iki hafta önce sağ gluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon yapıldığını, sonrasında yürürken pelvisinin karşı tarafa düştüğünü fark ettiğini belirtmektedir.

Demografi: 44 yaşında kadın hasta | Setting: nöroloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta sağ bacak üzerinde tek ayak durduğunda sol pelvis aşağı düşmektedir.
- Sağ kalça abduksiyonu zayıftır.
- Diz ekstansiyonu ve ayak dorsifleksiyonu korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanması en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus gluteus superior
- B) Nervus gluteus inferior
- C) Nervus femoralis
- D) Nervus obturatorius
- E) Nervus tibialis

Doğru Cevap: Nervus gluteus superior

- A) Nervus gluteus superior: Nervus gluteus superior gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını innerve ettiği için kalça abduksiyon zayıflığı ve Trendelenburg bulgusunu açıklar. Vakadaki "Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır." ve "Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Nervus gluteus inferior: Nervus gluteus inferior gluteus maximus kasını innerve eder ve kalça ekstansiyonu ile ilişkilidir; pelvis stabilizasyon kaybını en iyi açıklamaz. Bu olguda "Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır." ve "Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nervus femoralis: Nervus femoralis diz ekstansiyonu ve anterior uyluk duyusuyla ilişkilidir; bu hastada diz ekstansiyonu korunmuştur. Bu olguda "Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır." ve "Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nervus obturatorius: Nervus obturatorius uyluk adduksiyonunu sağlar; kalça abduksiyon zayıflığı ve Trendelenburg bulgusu için uygun değildir. Bu olguda "Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır." ve "Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus tibialis: Nervus tibialis plantar fleksiyon ve ayak tabanı duyusuyla ilişkilidir; gluteal abduktör fonksiyonunu açıklamaz. Bu olguda "Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır." ve "Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nervus gluteus superior seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kalça enjeksiyonu sonrası yürüme bozukluğu olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır." ve "Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir." birlikte okunduğunda Nervus gluteus superior seçeneği öne çıkar; "Sağ kalça abduksiyonu zayıflamıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nervus gluteus superior gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını innerve eder. Bu kaslar tek ayak durumunda pelvisi stabilize eder; hasarında karşı pelvis düşer ve Trendelenburg bulgusu gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır.", "Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir." ve "Sağ kalça abduksiyonu zayıflamıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus gluteus superior en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakınmalar gluteal bölge enjeksiyonu sonrasında başlamıştır.

Kanıt 2: Sağ bacak üzerinde durunca sol pelvis aşağı düşmektedir.

Kanıt 3: Sağ kalça abduksiyonu zayıflamıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Trendelenburg bulgusu gluteus medius-minimus zayıflığı ve nervus gluteus superior hasarıyla ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 272: v189-new-272-temporal-travma-sonrasi-bilinc-kotulesmesi

Başlık: Temporal travma sonrası bilinç kötüleşmesi

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulguyla ilişkilendirme.

Learning Target: Pterion kırığında arteria meningeae media yaralanmasını epidural hematomla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, başına darbe aldıktan sonra kısa süre düzelen ancak sonra kötülen bilinç durumu nedeniyle getiriliyor. Futbol sırasında sağ temporal bölgeye darbe aldığı, kısa süre bilincini kaybettiği ve ardından konuşabildiği öğreniliyor. Bir saat sonra şiddetli baş ağrısı ve uykuya eğilim gelişmiştir.

Demografi: 23 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste travma ekibi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 146/86 mmHg | Nabız: 58/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,40

Fizik Muayene

- Hasta somnolandır.
- Sağ temporal bölgede hassasiyet vardır.
- Sol pupil sağa göre hafif geniştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kraniyal bilgisayarlı tomografi

Etiket: Kraniyal bilgisayarlı tomografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ temporal bölgede bikonveks ekstraaksiyel hiperdens kanama izlendi. | Klinik anlam: Epidural hematoma ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Epidural hematoma ile uyumludur. | Sonuç başlığı: Kraniyal bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Sağ temporal bölgede bikonveks ekstraaksiyel hiperdens kanama izlendi. | Yorum: Epidural hematoma ile uyumludur. | Satırlar: Kraniyal bilgisayarlı tomografi / Sağ temporal bölgede bikonveks ekstraaksiyel hiperdens kanama izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görseller

Görsel 1: ID: visual-138 | Başlık: Kraniyal bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Sağ temporal bölgede bikonveks ekstraaksiyel hiperdens kanama izlendi. | Klinik anlam: Epidural hematoma ile uyumludur. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/138_epidural_hematoma_kranial_bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/138_epidural_hematoma_kranial_bt.webp | Alt text: Kraniyal bilgisayarlı tomografi - Sağ temporal bölgede bikonveks ekstraaksiyel hiperdens kanama izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu kanamanın en olası kaynak damarı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Arteria meningeae media
- B) Arteria cerebri anterior
- C) Arteria cerebri posterior
- D) Vena cerebri magna
- E) Sinus sagittalis superior

Doğru Cevap: Arteria meningeae media

A) Arteria meningeae media: Arteria meningeae media pterion derininde seyredir ve epidural hematomaun klasik kaynak damarıdır. Vakadaki “Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.” ve “Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Arteria cerebri anterior: Arteria cerebri anterior medial frontal-parietal beyin alanlarını besler; pterion kırığına bağlı epidural kanamanın tipik kaynağı değildir. Bu olguda “Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.” ve “Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Arteria meningeae media seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Arteria cerebri posterior: Arteria cerebri posterior oksipital lob ve inferior temporal alanları besler; bikonveks epidural hematoma paternini açıklamaz. Bu olguda “Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.” ve “Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Arteria meningeae media seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Vena cerebri magna: Vena cerebri magna derin venöz drenaja ilişkilidir; temporal epidural hematomaun klasik kaynağı değildir. Bu olguda “Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.” ve “Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Arteria meningeae media seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Sinus sagittalis superior: Sinus sagittalis superior venöz sinüştür ve orta hatta seyredir; pterion travmasıyla ilişkili tipik damar değildir. Bu olguda “Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.” ve “Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Arteria meningeae media seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Temporal travma sonrası bilinç kötülenmesi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.” ve “Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.” birlikte okunduğunda Arteria meningeae media seçeneği öne çıkar; “BT’de bikonveks ekstraaksiyel kanama görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Pterion bölgesi ince kemik yapısı nedeniyle travmada kırılabilir ve hemen altında seyreden arteria meningeae media yaralanabilir. Arteriyel kanama dura ile kafatası arasında bikonveks epidural hematoma oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.”, “Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.” ve “BT’de bikonveks ekstraaksiyel kanama görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Arteria meningeae media en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Travma sağ temporal bölgeye alınmıştır.

Kanıt 2: Kısa düzelmeye döneminden sonra bilinç kötülenmiştir.

Kanıt 3: BT’de bikonveks ekstraaksiyel kanama görülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Pterion kırığı arteria meningeae media yırtığına ve epidural hematoma yol açabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 273:

v189-new-273-duvara-itme-sirasinda-kurek-kemigi-belirginlesmesi

Başlık: Duvara itme sırasında kürek kemiği belirginleşmesi

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulguyla ilişkilendirme.

Learning Target: Nervus thoracicus longus hasarını scapula alata bulgusuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, koltuk altı bölgesine aldığı travma sonrası sağ omuz çevresinde güçsüzlük nedeniyle başvuruyor. Dağcılık sırasında sırt çantasının omuz ve aksilla bölgesine uzun süre baskı yaptığını, sonrasında duvara iterken kürek kemiğinin dışarı çıktığını fark ettiğini belirtmektedir.

Demografi: 31 yaşında erkek hasta | Setting: fizik tedavi polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta iki eliyle duvara ittiğinde sağ skapulanın medial kenarı belirgin şekilde kanatlanmaktadır.
- Omuz abdüksiyonu başlangıçta mümkündür ancak kolu baş üzerine kaldırmada zorlanır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanması en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus thoracicus longus
- B) Nervus dorsalis scapulae
- C) Nervus suprascapularis
- D) Nervus axillaris
- E) Nervus subscapularis

Doğru Cevap: Nervus thoracicus longus

A) Nervus thoracicus longus: Nervus thoracicus longus serratus anterior kasını innerve ettiği için duvara itme sırasında belirginleşen scapula alatayı açıklar. Vakadaki “Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.” ve “Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Nervus dorsalis scapulae: Nervus dorsalis scapulae rhomboid kasları innerve eder; klasik medial kenar kanatlanmasının en tipik nedeni değildir. Bu olguda “Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.” ve “Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus suprascapularis: Nervus suprascapularis supraspinatus ve infraspinatus kaslarını etkiler; skapulanın toraks duvarına sabitlenmesini sağlamaz. Bu olguda “Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.” ve “Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nervus axillaris: Nervus axillaris deltoide ve teres minor kaslarıyla ilişkilidir; scapula alata için en uygun sinir değildir. Bu olguda “Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.” ve “Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus subscapularis: Nervus subscapularis subscapularis ve teres major kaslarıyla ilişkilidir; serratus anterior fonksiyonunu açıklamaz. Bu olguda “Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.” ve “Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus thoracicus longus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Duvara itme sırasında kürek kemiği belirginleşmesi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.” ve “Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.” birlikte okunduğunda Nervus thoracicus longus seçeneği öne çıkar; “Kolu baş üzerine kaldırmada zorlanma vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nervus thoracicus longus serratus anterior kasını innerve eder. Serratus anterior skapulayı toraks duvarına sabitler ve yukarı rotasyona katkı sağlar; hasarında scapula alata gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.”, “Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.” ve “Kolu baş üzerine kaldırmada zorlanma vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus thoracicus longus en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakınmalar aksilla ve lateral toraks bölgesine bası sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Duvara itme sırasında skapulanın medial kenarı kanatlanmaktadır.

Kanıt 3: Kolu baş üzerine kaldırmada zorlanma vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Scapula alata en klasik olarak nervus thoracicus longus ve serratus anterior hasarıyla ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 274: v189-new-274-kalp-yetmezliginde-bacak-odemi

Başlık: Kalp yetmezliğinde bacak ödemi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Kapiller Starling kuvvetlerinde hidrostatik basınç artışına bağlı ödeme mekanizmasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, iki bacakta giderek artan şişlik ve efor dispnesi nedeniyle başvuruyor. Bilinen kalp yetmezliği olduğu, son haftalarda tuz tüketiminin arttığı ve ayak bileklerinde şişlik geliştiği öğreniliyor. Protein kaybı öyküsü yoktur.

Demografi: 67 yaşında erkek hasta | Setting: kardiyoloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 132/78 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,73

Fizik Muayene

- Bilateral pretibial gode bırakan ödeme vardır.
- Akciğer bazallerinde ince raller duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum albümin

Etiket: Serum albümin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Onkotik basınç azalmasını geri plana iter. | Sonuç yorumu: Onkotik basınç azalmasını geri plana iter. | Sonuç başlığı: Serum albümin | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Onkotik basınç azalmasını geri plana iter. | Satırlar: Serum albümin / Normal saptandı. / 4.1 g/dL / 3.5-5.0 g/dL

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki periferik ödemi en iyi açıklayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi
B) Plazma onkotik basıncının ağır azalması
C) Lenfatik drenajın doğuştan tamamen olmaması
D) Eritrosit oksijen taşıma kapasitesinin artması
E) Kapiller filtrasyon katsayısının sıfıra düşmesi

Doğru Cevap: Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi

A) Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi: Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basınç yükselmesi kalp yetmezliğinde gode bırakan ödemi açıklar. Vakadaki "Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır." ve "Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Plazma onkotik basıncının ağır azalması: Plazma onkotik basıncının ağır azalması nefrotik sendrom veya karaciğer yetmezliği gibi durumlarda beklenir; albümin normaldir. Bu olguda "Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır." ve "Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Lenfatik drenajın doğuştan tamamen olmaması: Lenfatik drenajın doğuştan tamamen olmaması bu yaşta yeni gelişen kalp yetmezliği ödemi açıklamaz. Bu olguda "Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır." ve "Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Eritrosit oksijen taşıma kapasitesinin artması: Eritrosit oksijen taşıma kapasitesinin artması interstisyel sıvı birikiminin mekanizması değildir. Bu olguda "Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır." ve "Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kapiller filtrasyon katsayısının sıfıra düşmesi: Vakadaki Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır ve Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır. Bu olguda "Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır." ve "Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kalp yetmezliğinde bacak ödemi olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır." ve "Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır." birlikte okunduğunda Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi seçeneği öne çıkar; "Serum albümin düzeyi normaldir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kalp yetmezliğinde venöz basınç artışı kapiller hidrostatik basıncı yükseltir. Bu durum sıvının interstisyuma geçişini artırır ve gode bırakan periferik ödeme oluşur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır.", "Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır." ve "Serum albümin düzeyi normaldir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Venöz basınç artışına bağlı kapiller hidrostatik basıncın yükselmesi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada bilinen kalp yetmezliği vardır.

Kanıt 2: Bilateral pretibial gode bırakan ödeme saptanmıştır.

Kanıt 3: Serum albümin düzeyi normaldir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Kalp yetmezliğinde ödemin ana mekanizması kapiller hidrostatik basınç artışıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 275: v189-new-275-su-kisitlamasinda-idrar-yogunlasmasi

Başlık: Su kısıtlamasında idrar yoğunlaşması

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: ADH etkisini toplayıcı kanalda aquaporin-2 yerleşimi ve idrar konsantrasyonu ile ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde su kısıtlaması sonrası idrarın nasıl yoğunlaştırıldığı tartışılıyor. Bilinen böbrek veya endokrin hastalığı yoktur. Değerlendirme su dengesi ve antidiüretik hormon etkisini anlamak için yapılmaktadır.

Demografi: 29 yaşında sağlıklı kadın gönüllü | Setting: fizyoloji laboratuvarında değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 110/68 mmHg | Nabız: 78/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Fizik muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Su kısıtlama simülasyonu

Etiket: Su kısıtlama simülasyonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Plazma osmolalitesi artmış ve antidiüretik hormon salınımı yükselmiş olarak modellendi. | Klinik anlam: ADH etkisinin değerlendirilmesini sağlar. | Sonuç yorumu: ADH etkisinin değerlendirilmesini sağlar. | Sonuç başlığı: Su kısıtlama simülasyonu | Sonuç özeti: Plazma osmolalitesi artmış ve antidiüretik hormon salınımı yükselmiş olarak modellendi. | Yorum: ADH etkisinin değerlendirilmesini sağlar. | Satırlar: Su kısıtlama simülasyonu / Plazma osmolalitesi artmış ve antidiüretik hormon salınımı yükselmiş olarak modellendi. // ADH etkisinin değerlendirilmesini sağlar.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Antidiüretik hormonun idrarı yoğunlaştıran temel hücresel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması
B) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunu başlatması
C) Henle çıkan kalın kolunu suya tamamen geçirgen hale getirmesi
D) Distal tübülde potasyum filtrasyonunu durdurması
E) Glomerüler filtrasyonu sıfıra indirmesi

Doğru Cevap: Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması

- A) Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması: Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 yerleşiminin artması ADH'nin idrarı yoğunlaştıran temel etkisidir. Vakadaki "Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır." ve "Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Proksimal tübülde glukoz sekresyonunu başlatması: Proksimal tübülde glukoz sekresyonu fizyolojik bir ADH etkisi değildir; glukoz normalde geri emilir. Bu olguda "Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır." ve "Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir." ipuçları klinik karar açısından Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Henle çıkan kalın kolunu suya tamamen geçirgen hale getirmesi: Henle çıkan kalın kolu normalde suya geçirgen değildir ve ADH'nin temel yoğunlaştırıcı etkisi burada su geçirgenliğini artırmak değildir. Bu olguda "Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır." ve "Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir." ipuçları klinik karar açısından Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Distal tübülde potasyum filtrasyonunu durdurması: Potasyum filtrasyonu glomerülde gerçekleşir; distal tübülde filtrasyonun durması şeklinde bir ADH mekanizması yoktur. Bu olguda "Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır." ve "Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir." ipuçları klinik karar açısından Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Glomerüler filtrasyonu sıfıra indirmesi: Vakadaki Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır ve Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir. Bu olguda "Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır." ve "Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir." ipuçları klinik karar açısından Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Su kısıtlamasında idrar yoğunlaşması olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır." ve "Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir." birlikte okunduğunda Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması seçeneği öne çıkar; "Soru idrar yoğunlaştırma mekanizmasını sorgulamaktadır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: ADH, V2 reseptörleri üzerinden toplayıcı kanal principal hücrelerinde aquaporin-2 kanallarının apikal membrana yerleşimini artırır. Böylece medüller osmotik gradyan boyunca su geri emilir ve idrar yoğunlaşır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır.", "Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir." ve "Soru idrar yoğunlaştırma mekanizmasını sorgulamaktadır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Toplayıcı kanal principal hücre apikal membranına aquaporin-2 kanallarının yerleşimini artırması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Su kısıtlaması plazma osmolalitesini artırmıştır.

Kanıt 2: Antidiüretik hormon salınımı yükselmiştir.

Kanıt 3: Soru idrar yoğunlaştırma mekanizmasını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: ADH, V2 reseptörü üzerinden aquaporin-2 yerleşimini artırarak su geri emilimini yükseltir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 276: v189-new-276-sivi-yuklenmesine-kardiyak-yanit

Başlık: Sıvı yüklenmesine kardiyak yanıt

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Frank-Starling mekanizmasında venöz dönüş artışının atım hacmine etkisini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde venöz dönüş arttığında kalbin atım hacminde beklenen değişiklik tartışılıyor. Bilinen kalp hastalığı yoktur. Değerlendirme normal kardiyak fizyoloji mekanizmasını göstermek için yapılmaktadır.

Demografi: 33 yaşında sağlıklı gönüllü | Setting: kardiyovasküler fizyoloji laboratuvarında değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 116/74 mmHg | Nabız: 72/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,62

Fizik Muayene

- Dinlenim muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemodinamik simülasyon

Etiket: Hemodinamik simülasyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Venöz dönüş ve diyastol sonu hacim artmış olarak modellendi. | Klinik anlam: Frank-Starling ilişkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç yorumu: Frank-Starling ilişkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç başlığı: Hemodinamik simülasyon | Sonuç özeti: Venöz dönüş ve diyastol sonu hacim artmış olarak modellendi. | Yorum: Frank-Starling ilişkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. | Satırlar: Hemodinamik simülasyon / Venöz dönüş ve diyastol sonu hacim artmış olarak modellendi. // Frank-Starling ilişkisini değerlendirmek için kullanılmıştır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Normal kalpte venöz dönüş artışı atım hacmini hangi mekanizmayla artırır?

- A) Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları
- B) Aksiyon potansiyelini tamamen durdurması
- C) Kalsiyum salınımını geri dönüşümsüz engellemesi
- D) Kalp kapaklarını kalıcı olarak kapatması
- E) Koroner kan akımını sıfıra düşürmesi

Doğru Cevap: Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları

- A) Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları: Miyokard lif uzunluğunun artması daha güçlü kasılma oluşturmaları Frank-Starling mekanizmasıyla atım hacmini artırır. Vakadaki "Simülasyonda venöz dönüş artmıştır." ve "Diyastol sonu hacim yükselmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Aksiyon potansiyelini tamamen durdurması: Vakadaki Simülasyonda venöz dönüş artmıştır ve Diyastol sonu hacim yükselmiştir. Bu olguda "Simülasyonda venöz dönüş artmıştır." ve "Diyastol sonu hacim yükselmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Kalsiyum salınımını geri dönüşümsüz engellemesi: Vakadaki Simülasyonda venöz dönüş artmıştır ve Diyastol sonu hacim yükselmiştir. Bu olguda "Simülasyonda venöz dönüş artmıştır." ve "Diyastol sonu hacim yükselmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Kalp kapaklarını kalıcı olarak kapatması: Kalp kapaklarının kalıcı kapanması dolaşımı bozar ve Frank-Starling mekanizmasıyla ilişkili değildir. Bu olguda "Simülasyonda venöz dönüş artmıştır." ve "Diyastol sonu hacim yükselmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Koroner kan akımını sıfıra düşürmesi: Vakadaki Simülasyonda venöz dönüş artmıştır ve Diyastol sonu hacim yükselmiştir. Bu olguda "Simülasyonda venöz dönüş artmıştır." ve "Diyastol sonu hacim yükselmiştir." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sıvı yüklenmesine kardiyak yanıt olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Simülasyonda venöz dönüş artmıştır." ve "Diyastol sonu hacim yükselmiştir." birlikte okunduğunda Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları seçeneği öne çıkar; "Değerlendirilen kalp normal fizyolojik yanıt göstermektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Frank-Starling mekanizmasına göre diyastol sonu hacim arttığında miyokard lifleri daha uygun uzunluğa gerilir. Bu, aktin-miyozin etkileşimini ve kasılma kuvvetini artırarak atım hacmini yükseltir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Simülasyonda venöz dönüş artmıştır.", "Diyastol sonu hacim yükselmiştir." ve "Değerlendirilen kalp normal fizyolojik yanıt göstermektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Miyokard lif uzunluğunu artırarak daha güçlü kasılma oluşturmaları en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Simülasyonda venöz dönüş artmıştır.

Kanıt 2: Diyastol sonu hacim yükselmiştir.

Kanıt 3: Değerlendirilen kalp normal fizyolojik yanıt göstermektedir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Frank-Starling mekanizması preload artışına karşı atım hacmini artıran intrinsik kardiyak yanittir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 277: v189-new-277-yenidoganda-surekli-ufurum

Başlık: Yenidoğanda sürekli üfürüm

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Duktus arteriozusun kapanma kusurunu prostaglandin etkisi ve sürekli üfürümle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, hızlı nefes alma ve beslenirken çabuk yorulma nedeniyle getiriliyor. Doğumdan sonra ilk haftalarda iyi olduğu, sonrasında beslenme süresinin uzadığı ve terleme geliştiği öğreniliyor. Prematüre doğum öyküsü vardır.

Demografi: 3 haftalık kız bebek | Setting: çocuk kardiyoloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulur.
- Hafif takipne vardır.
- Nabız basıncı geniştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Aort ile pulmoner arter arasında patent duktus arteriozus izlendi. | Klinik anlam: Fetal dolaşım bağlantısının açık kaldığını gösterir. | Sonuç yorumu: Fetal dolaşım bağlantısının açık kaldığını gösterir. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Aort ile pulmoner arter arasında patent duktus arteriozus izlendi. | Yorum: Fetal dolaşım bağlantısının açık kaldığını gösterir. | Satırlar: Ekokardiyografi / Aort ile pulmoner arter arasında patent duktus arteriozus izlendi. // Fetal dolaşım bağlantısının açık kaldığını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-139 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Aort ile pulmoner arter arasında patent duktus arteriozus izlendi. | Klinik anlam: Fetal dolaşım bağlantısının açık kaldığını gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/139_patent_duktus_arteriozus_eko.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/139_patent_duktus_arteriozus_eko.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Aort ile pulmoner arter arasında patent duktus arteriozus izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yapının fetal dönemde açık kalmasını en çok destekleyen mediyatör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prostaglandin E2
B) Asetilkolin
C) Tiroksin
D) Aldosteron
E) Gastrin

Doğru Cevap: Prostaglandin E2

- A) Prostaglandin E2: Prostaglandin E2 fetal duktus arteriozus açıklığını sürdüren temel mediyatördür. Vakadaki “Bebekte prematürite öyküsü vardır.” ve “Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Asetilkolin: Asetilkolin parasempatik sinaptik iletimde önemlidir; duktus arteriozus açıklığının ana mediyatörü değildir. Bu olguda “Bebekte prematürite öyküsü vardır.” ve “Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Prostaglandin E2 seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Tiroksin: Vakadaki Bebekte prematürite öyküsü vardır ve Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır. Bu olguda “Bebekte prematürite öyküsü vardır.” ve “Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Prostaglandin E2 seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Aldosteron: Vakadaki Bebekte prematürite öyküsü vardır ve Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır. Bu olguda “Bebekte prematürite öyküsü vardır.” ve “Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Prostaglandin E2 seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Gastrin: Vakadaki Bebekte prematürite öyküsü vardır ve Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır. Bu olguda “Bebekte prematürite öyküsü vardır.” ve “Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Prostaglandin E2 seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda sürekli üfürüm olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Bebekte prematürite öyküsü vardır.” ve “Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.” birlikte okunduğunda Prostaglandin E2 seçeneği öne çıkar; “Ekokardiyografide patent duktus arteriozus gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Duktus arteriozus fetal dönemde prostaglandin E2 etkisiyle açık kalır. Doğumdan sonra oksijen basıncının artması ve prostaglandin düzeyinin azalması kapanmayı sağlar; açık kalırsa sürekli üfürüm gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte prematürite öyküsü vardır.”, “Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.” ve “Ekokardiyografide patent duktus arteriozus gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Prostaglandin E2 en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Bebekte prematürite öyküsü vardır.

Kanıt 2: Sol infraklaviküler bölgede sürekli makine tarzı üfürüm duyulmaktadır.

Kanıt 3: Ekokardiyografide patent duktus arteriozus gösterilmiştir.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguyla uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: PGE2 duktusu açık tutar; indometazin kapanmayı destekler, alprostadil açıklığı sürdürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 278: v189-new-278-emilim-yuzeyinin-histolojik-temeli

Başlık: Emilim yüzeyinin histolojik temeli

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Histolojik yapıyı klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: İnce bağırsak emilim yüzeyini artıran villus ve mikrovillus yapılarını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

İnce bağırsakta besin emilimini artıran histolojik yapıların tanımlanması isteniyor. Hasta malabsorpsiyon açısından incelenmiş ve duodenum biyopsisi alınmıştır. Soru normal emilim yüzeyinin histolojik organizasyonuna yöneliktir.

Demografi: 35 yaşında erkek hasta | Setting: gastroenteroloji eğitiminde ince bağırsak biyopsisi üzerinden değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fizik muayenede belirgin akut bulgu yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Duodenum biyopsisi

Etiket: Duodenum biyopsisi | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Mukozada villuslar ve enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlendi. | Klinik anlam: Emilim yüzeyini artıran yapıları gösterir. | Sonuç yorumu: Emilim yüzeyini artıran yapıları gösterir. | Sonuç başlığı: Duodenum biyopsisi | Sonuç özeti: Mukozada villuslar ve enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlendi. | Yorum: Emilim yüzeyini artıran yapıları gösterir. | Satırlar: Duodenum biyopsisi / Mukozada villuslar ve enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlendi. // Emilim yüzeyini artıran yapıları gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-140 | Başlık: Duodenum biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Mukozada villuslar ve enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlendi. | Klinik anlam: Emilim yüzeyini artıran yapıları gösterir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/140_duodenum_villus_fircamsi_kenar_histoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/140_duodenum_villus_fircamsi_kenar_histoloji.webp | Alt text: Duodenum biyopsisi - Mukozada villuslar ve enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Enterosit apikal yüzündeki fırçamsı kenarı oluşturan temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mikrovillus
B) Silyum
C) Desmozom
D) Bazal lamina
E) Hemidesmozom

Doğru Cevap: Mikrovillus

- A) Mikrovillus: Mikrovillus enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenarı oluşturur ve emilim yüzeyini artırır. Vakadaki “Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.” ve “Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Silyum: Silyum hareket işleviyle ilişkilidir; ince bağırsak emilim yüzeyinin temel fırçamsı kenar yapısı değildir. Bu olguda “Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.” ve “Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Mikrovillus seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Desmozom: Desmozom hücreler arası mekanik bağlantı sağlar; apikal emilim yüzeyini oluşturan çıkıntı değildir. Bu olguda “Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.” ve “Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Mikrovillus seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Bazal lamina: Bazal lamina epitelin altında destek tabakasıdır; enterosit apikal fırçamsı kenarını oluşturmaz. Bu olguda “Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.” ve “Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Mikrovillus seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Hemidesmozom: Hemidesmozom epitel hücrelerini bazal laminaya bağlar; mikrovillus gibi emilim yüzeyini artırmaz. Bu olguda “Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.” ve “Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Mikrovillus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Emilim yüzeyinin histolojik temeli olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.” ve “Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Mikrovillus seçeneği öne çıkar; “Soru emilim yüzeyini artıran hücresel yapıyı sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İnce bağırsakta villuslar mukozal yüzeyi, enterositlerin apikal mikrovillusları ise hücresel emilim yüzeyini artırır. Mikrovillusların oluşturduğu fırçamsı kenar sindirim enzimleri ve taşıyıcılar açısından önemlidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.”, “Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.” ve “Soru emilim yüzeyini artıran hücresel yapıyı sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Mikrovillus en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Biyopsi ince bağırsak mukozasından alınmıştır.

Kanıt 2: Enterosit apikal yüzünde fırçamsı kenar izlenmiştir.

Kanıt 3: Soru emilim yüzeyini artıran hücresel yapıyı sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguyla uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: İnce bağırsak fırçamsı kenarı mikrovilluslardan oluşur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 279: v189-new-279-yenidoganda-solunum-sikintisi-ve-barsak-sesleri

Başlık: Yenidoğanda solunum sıkıntısı ve barsak sesleri

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Konjenital diyafram hernisini pleuroperitoneal membran kapanma kusuruyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı ve siyanoz nedeniyle entübe ediliyor. Prenatal ultrasonda toraks içinde barsak ansları görüldüğü belirtilmiştir. Doğum sonrası solunum sıkıntısı hızla belirginleşmiştir.

Demografi: 1 saatlik erkek yenidoğan | Setting: yenidoğan yoğun bakımda değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebekte scaphoid abdomen görünümü vardır.
- Sol hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve barsak sesleri duyulmaktadır.
- Oksijen satürasyonu düşüktür.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol hemitoraksta barsak ansları ve mediastinal şift izlendi. | Klinik anlam: Konjenital diyafram hernisi ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Konjenital diyafram hernisi ile uyumludur. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Sol hemitoraksta barsak ansları ve mediastinal şift izlendi. | Yorum: Konjenital diyafram hernisi ile uyumludur. | Satırlar: Akciğer grafisi / Sol hemitoraksta barsak ansları ve mediastinal şift izlendi. / / Konjenital diyafram hernisi ile uyumludur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-141 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sol hemitoraksta barsak ansları ve mediastinal şift izlendi. | Klinik anlam: Konjenital diyafram hernisi ile uyumludur. | URL: https://iukbtlkzictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/141_konjenital_diyafram_hernisi_yenidogan_grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/141_konjenital_diyafram_hernisi_yenidogan_grafi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Sol hemitoraksta barsak ansları ve mediastinal şift izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu anomalinin temel embriyolojik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pleuroperitoneal membranın kapanmaması
B) Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi
C) Omfalomezenterik kanalın açık kalması
D) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu
E) Üçüncü faringeal poşun gelişmemesi

Doğru Cevap: Pleuroperitoneal membranın kapanmaması

- A) Pleuroperitoneal membranın kapanmaması: Pleuroperitoneal membranın kapanmaması abdominal organların toraksa herniasyonunu ve solunum sıkıntısını açıklar. Vakadaki “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.” ve “Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi: Nöral krest hücrelerinin distal bağırsağa göç edememesi Hirschsprung hastalığına yol açar; diyafram defekti yapmaz. Bu olguda “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.” ve “Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pleuroperitoneal membranın kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Omfalomezenterik kanalın açık kalması: Vakadaki Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir ve Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır. Bu olguda “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.” ve “Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pleuroperitoneal membranın kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Septum primumun aşırı rezorpsiyonu: Vakadaki Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir ve Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır. Bu olguda “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.” ve “Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pleuroperitoneal membranın kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Üçüncü faringeal poşun gelişmemesi: Üçüncü faringeal poşun gelişmemesi timus ve paratiroid hipoplazisiyle ilişkilidir; diyafram hernisi yapmaz. Bu olguda “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.” ve “Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Pleuroperitoneal membranın kapanmaması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda solunum sıkıntısı ve barsak sesleri olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.” ve “Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.” birlikte okunduğunda Pleuroperitoneal membranın kapanmaması seçeneği öne çıkar; “Grafide toraks içinde barsak ansları ve mediastinal şift görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Konjenital diyafram hernisi en sık posterolateral diyafram defektiyle ilişkilidir ve pleuroperitoneal membranın kapanma kusurundan kaynaklanır. Abdominal organlar toraksa geçerek akciğer hipoplazisi ve ağır solunum sıkıntısı yapabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.”, “Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.” ve “Grafide toraks içinde barsak ansları ve mediastinal şift görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pleuroperitoneal membranın kapanmaması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Doğumdan hemen sonra ağır solunum sıkıntısı gelişmiştir.

Kanıt 2: Sol hemitoraksta barsak sesleri duyulmaktadır.

Kanıt 3: Grafide toraks içinde barsak ansları ve mediastinal şift görülmüştür.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Bochdalek tipi konjenital diyafram hernisi pleuroperitoneal membran kapanma kusuruyla ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 280: v189-new-280-karbonhidrat-sonrasi-laktik-asidoz

Başlık: Karbonhidrat sonrası laktik asidoz

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Pirüvat dehidrogenaz eksikliğinde laktik asidoz ve alanin artışı açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, gelişim geriliği, hipotoni ve tekrarlayan laktik asidoz atakları nedeniyle getiriliyor. Ailesi özellikle karbonhidrattan zengin beslenme sonrası huzursuzluk ve solunum hızında artış olduğunu belirtmektedir. Nörolojik gelişimi yaşitlarına göre geridir.

Demografi: 6 aylık erkek bebek | Setting: çocuk metabolizma polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebekte hipotoni ve baş kontrolünde gecikme vardır.
- Karaciğer belirgin büyük değildir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Laktik asidozu destekler. | Sonuç yorumu: Laktik asidozu destekler. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Laktik asidozu destekler. | Satırlar: Serum laktat / Yüksek saptandı. / 7.4 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L

Tetkik 2: Plazma alanin

Etiket: Plazma alanin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Pirüvat birikimiyle uyumludur. | Sonuç yorumu: Pirüvat birikimiyle uyumludur. | Sonuç başlığı: Plazma alanin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Pirüvat birikimiyle uyumludur. | Satırlar: Plazma alanin / Yüksek saptandı. // Pirüvat birikimiyle uyumludur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel biyokimyasal sorun aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması
B) Fenilalaninin tirozine dönüşümünün artması
C) Glukoz-6-fosfatın serbest glukoz dönüşümünün artması
D) Ürenin amonyağa dönüşümünün artması
E) Yağ asitlerinin sitozolde tam oksidasyonu

Doğru Cevap: Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması

- A) Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması: Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması laktat ve alanin artışı sağlayan temel defektir. Vakadaki "Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Fenilalaninin tirozine dönüşümünün artması: Vakadaki Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır ve Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda "Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları klinik karar açısından Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Glukoz-6-fosfatın serbest glukoz dönüşümünün artması: Glukoz-6-fosfatın serbest glukoz dönüşümünün artması hipoglisemi değil glukoz üretimini artırır; bu tabloyla uyumlu değildir. Bu olguda "Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları klinik karar açısından Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ürenin amonyağa dönüşümünün artması: Vakadaki Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır ve Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda "Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları klinik karar açısından Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Yağ asitlerinin sitozolde tam oksidasyonu: Vakadaki Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır ve Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir. Bu olguda "Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir." ipuçları klinik karar açısından Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Karbonhidrat sonrası laktik asidoz olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır." ve "Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir." birlikte okunduğunda Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması seçeneği öne çıkar; "Plazma alanin düzeyi yüksek saptanmıştır." ise ayrıncı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Pirüvat dehidrogenaz eksikliğinde pirüvat asetil-KoA'ya yeterince dönüştürülemez. Pirüvat laktat ve alanin yollarına yönelir; laktik asidoz ve nörolojik bulgular gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır.", "Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir." ve "Plazma alanin düzeyi yüksek saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pirüvatın asetil-KoA'ya dönüşümünün azalması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada gelişim geriliği ve hipotoni vardır.

Kanıt 2: Serum laktat düzeyi belirgin yüksektir.

Kanıt 3: Plazma alanin düzeyi yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: PDH eksikliğinde pirüvat laktata yönelir; karbonhidrat yükü tabloyu ağırlaştırabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 281: v189-new-281-bebekte-gelisim-gerilemesi-ve-makula-bulgusu

Başlık: Bebekte gelişim gerilemesi ve makula bulgusu

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Tay-Sachs hastalığında heksozaminidaz A eksikliğini nörodejenerasyon ve kiraz kırmızısı makula ile ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, kazanılmış motor becerilerde kayıp ve çevreye ilgide azalma nedeniyle getiriliyor. İlk aylarda gelişiminin normal olduğu, sonrasında baş kontrolünün zayıfladığı ve sese aşırı irkilme geliştiği öğreniliyor. Akraba evliliği vardır.

Demografi: 9 aylık kız bebek | Setting: çocuk nöroloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebekte hipotoni ve çevreye ilgide azalma vardır.
- Hepatosplenomegali saptanmaz.
- Göz dibi muayenesinde kiraz kırmızısı makula bildirilmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Lökosit enzim analizi

Etiket: Lökosit enzim analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Heksozaminidaz A aktivitesi düşük saptandı. | Klinik anlam: Tay-Sachs hastalığını destekler. | Sonuç yorumu: Tay-Sachs hastalığını destekler. | Sonuç başlığı: Lökosit enzim analizi | Sonuç özeti: Heksozaminidaz A aktivitesi düşük saptandı. | Yorum: Tay-Sachs hastalığını destekler. | Satırlar: Lökosit enzim analizi / Heksozaminidaz A aktivitesi düşük saptandı. // Tay-Sachs hastalığını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta biriken temel madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GM2 gangliozid
B) Glukoserebrozid
C) Sfingomiyelin
D) Homogentisik asit
E) Fenilalanin

Doğru Cevap: GM2 gangliozid

A) GM2 gangliozid: GM2 gangliozid heksozaminidaz A eksikliğinde birikir ve Tay-Sachs tablosunu açıklar. Vakadaki “Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.” ve “Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Glukoserebrozid: Vakadaki Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır ve Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.” ve “Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından GM2 gangliozid seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Sfingomiyelin: Vakadaki Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır ve Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.” ve “Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından GM2 gangliozid seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Homogentisik asit: Vakadaki Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır ve Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.” ve “Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından GM2 gangliozid seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Fenilalanin: Fenilalanin fenilketonüride birikir; kiraz kırmızısı makula ve heksozaminidaz A eksikliğiyle ilişkili değildir. Bu olguda “Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.” ve “Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından GM2 gangliozid seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bebekte gelişim gerilemesi ve makula bulgusu olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.” ve “Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.” birlikte okunduğunda GM2 gangliozid seçeneği öne çıkar; “Heksozaminidaz A aktivitesi düşük bulunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tay-Sachs hastalığında heksozaminidaz A eksikliği GM2 gangliozid yıkımını bozar. Nörodejenerasyon, abartılı irkilme ve kiraz kırmızısı makula görülür; hepatosplenomegali beklenmez. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.”, “Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.” ve “Heksozaminidaz A aktivitesi düşük bulunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle GM2 gangliozid en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte gelişim gerilemesi ve hipotoni vardır.

Kanıt 2: Göz dibinde kiraz kırmızısı makula saptanmıştır.

Kanıt 3: Heksozaminidaz A aktivitesi düşük bulunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Tay-Sachs hastalığında GM2 gangliozid birikir ve hepatosplenomegali genellikle yoktur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 282: v189-new-282-cig-yumurta-tuketimi-sonrasi-dermatit

Başlık: Çiğ yumurta tüketimi sonrası dermatit

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Biyotin eksikliğinde karboksilaz reaksiyonlarının bozulmasını klinik bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, saç dökülmesi, dermatit ve halsizlik nedeniyle başvuruyor. Vücut geliştirme amacıyla uzun süredir çiğ yumurta akı tükettiği öğreniliyor. Son aylarda perioral döküntü, saçlarda seyrelme ve kas ağrıları gelişmiştir.

Demografi: 24 yaşında erkek hasta | Setting: iç hastalıkları polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Perioral eritemli dermatit ve saçlarda seyrelme vardır.
- Nörolojik muayenede hafif parestezi tarifler.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Beslenme öyküsü değerlendirmesi

Etiket: Beslenme öyküsü değerlendirmesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Uzun süreli çiğ yumurta akı tüketimi saptandı. | Klinik anlam: Avidin aracılığıyla biyotin bağlanmasını düşündürür. | Sonuç yorumu: Avidin aracılığıyla biyotin bağlanmasını düşündürür. | Sonuç başlığı: Beslenme öyküsü değerlendirmesi | Sonuç özeti: Uzun süreli çiğ yumurta akı tüketimi saptandı. | Yorum: Avidin aracılığıyla biyotin bağlanmasını düşündürür. | Satırlar: Beslenme öyküsü değerlendirmesi / Uzun süreli çiğ yumurta akı tüketimi saptandı. // Avidin aracılığıyla biyotin bağlanmasını düşündürür.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu eksiklikte en çok etkilenen enzim sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Karboksilazlar
B) Dehidrogenazlar
C) Fosfatazlar
D) Proteazlar
E) Helikazlar

Doğru Cevap: Karboksilazlar

A) Karboksilazlar: Karboksilazlar biyotin bağımlı enzimlerdir ve biyotin eksikliğinde en çok etkilenen sınıftır. Vakadaki “Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.” ve “Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Dehidrogenazlar: Dehidrogenazlar çoğunlukla NAD, FAD veya benzeri kofaktörlerle ilişkilidir; biyotinin ana hedef sınıfı değildir. Bu olguda “Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.” ve “Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karboksilazlar seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Fosfatazlar: Vakadaki Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir ve Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir. Bu olguda “Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.” ve “Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karboksilazlar seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Proteazlar: Vakadaki Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir ve Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir. Bu olguda “Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.” ve “Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karboksilazlar seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Helikazlar: Vakadaki Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir ve Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir. Bu olguda “Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.” ve “Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Karboksilazlar seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Çiğ yumurta tüketimi sonrası dermatit olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.” ve “Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Karboksilazlar seçeneği öne çıkar; “Soru biyotinin kofaktör olduğu reaksiyon sınıfını sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çiğ yumurta akındaki avidin biyotini bağlayarak emilimini azaltabilir. Biotin pirüvat karboksilaz, asetil-KoA karboksilaz ve propiyonil-KoA karboksilaz gibi karboksilaz reaksiyonlarında kofaktördür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.”, “Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.” ve “Soru biyotinin kofaktör olduğu reaksiyon sınıfını sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Karboksilazlar en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hasta uzun süre çiğ yumurta akı tüketmiştir.

Kanıt 2: Perioral dermatit ve saç dökülmesi gelişmiştir.

Kanıt 3: Soru biyotinin kofaktör olduğu reaksiyon sınıfını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Biotin karboksilaz reaksiyonlarının kofaktörüdür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 283: v189-new-283-otel-konaklamasi-sonrasi-pnomoni

Başlık: Otel konaklaması sonrası pnömoni

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla ilişkilendirme.

Learning Target: Legionella pneumophila enfeksiyonunu atipik pnömoni ve idrar antijeniyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, kuru öksürük, ishal ve bilinç bulanıklığı nedeniyle başvuruyor. Bir hafta önce otelde konakladığı ve klima-havuz alanlarını kullandığı öğreniliyor. Son üç gündür yüksek ateş, halsizlik ve sulu ishal gelişmiştir.

Demografi: 57 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste göğüs hastalıkları tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 39.2°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdı yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta konfüzyona eğilimlidir.
- Akciğer sağ alt alanda inspiratuvar raller duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Legionella pnömonisinde görülebilecek destekleyici bulgudur. | Sonuç yorumu: Legionella pnömonisinde görülebilecek destekleyici bulgudur. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Legionella pnömonisinde görülebilecek destekleyici bulgudur. | Satırlar: Serum sodyum / Düşük saptandı. / 128 mmol/L / 135-145 mmol/L

Tetkik 2: İdrar antijen testi

Etiket: İdrar antijen testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Legionella pneumophila serogrup 1 antijeni pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni destekler. | Sonuç yorumu: Etkeni destekler. | Sonuç başlığı: İdrar antijen testi | Sonuç özeti: Legionella pneumophila serogrup 1 antijeni pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni destekler. | Satırlar: İdrar antijen testi / Legionella pneumophila serogrup 1 antijeni pozitif saptandı. / Etkeni destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Legionella pneumophila
B) Streptococcus pyogenes
C) Bordetella pertussis
D) Clostridium tetani
E) Neisseria gonorrhoeae

Doğru Cevap: Legionella pneumophila

- A) Legionella pneumophila: Legionella pneumophila su sistemi maruziyeti, atipik pnömoni, ishal, hiponatremi ve pozitif idrar antijeniyle en uyumlu etkindir. Vakadaki "Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır." ve "Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Streptococcus pyogenes: Streptococcus pyogenes farenjit ve cilt enfeksiyonlarıyla ilişkilidir; bu atipik pnömoni paternini açıklamaz. Bu olguda "Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır." ve "Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir." ipuçları tanısallık açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Bordetella pertussis: Bordetella pertussis paroksizmal öksürük ve boğmaca tablosu yapar; otel su sistemi ilişkili pnömoni beklenmez. Bu olguda "Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır." ve "Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir." ipuçları tanısallık açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Clostridium tetani: Clostridium tetani kirli yara sonrası spastik paralizi yapar; pnömoni ve hiponatremi tablosuyla uyumlu değildir. Bu olguda "Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır." ve "Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir." ipuçları tanısallık açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Neisseria gonorrhoeae: Neisseria gonorrhoeae ürogenital enfeksiyon ve dissemine artrit-dermatit sendromuyla ilişkilidir; bu pnömoni tablosunu açıklamaz. Bu olguda "Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır." ve "Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir." ipuçları tanısallık açısından Legionella pneumophila seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Otel konaklaması sonrası pnömoni olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. "Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır." ve "Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda Legionella pneumophila seçeneği öne çıkar; "İdrar antijen testi Legionella pneumophila için pozitifdir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Otel-klima veya su sistemleri maruziyeti sonrası ateşli pnömoni, gastrointestinal bulgular, konfüzyon, hiponatremi ve pozitif idrar antijeni Legionella pneumophila enfeksiyonunu düşündürür. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır.", "Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir." ve "İdrar antijen testi Legionella pneumophila için pozitifdir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Legionella pneumophila en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada otel ve su sistemi maruziyeti vardır.

Kanıt 2: Pnömoniye ishal ve konfüzyon eşlik etmektedir.

Kanıt 3: İdrar antijen testi Legionella pneumophila için pozitifdir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Legionella pnömonisinde gastrointestinal bulgular, hiponatremi ve su sistemi maruziyeti önemli ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 284: v189-new-284-antibiyotik-sonrasi-oral-plaklar

Başlık: Antibiyotik sonrası oral plaklar

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla ilişkilendirme.

Learning Target: Candida albicans enfeksiyonunu psödohif ve germ tüp testiyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ağız içinde yanma ve silinebilir beyaz plaklar nedeniyle başvuruyor. Geniş spektrumlu antibiyotik kullandığı ve tip 2 diyabeti olduğu öğreniliyor. Son günlerde dil ve yanak mukozasında beyazlıklar gelişmiştir.

Demografi: 63 yaşında kadın hasta | Setting: enfeksiyon hastalıkları polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Oral mukozada kazınınca altı eritemli kalan beyaz plaklar izlenir.
- Ateşi yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: KOH incelemesi

Etiket: KOH incelemesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Tomurcuklanan maya hücreleri ve psödohif yapıları izlendi. | Klinik anlam: Candida enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Candida enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: KOH incelemesi | Sonuç özeti: Tomurcuklanan maya hücreleri ve psödohif yapıları izlendi. | Yorum: Candida enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: KOH incelemesi / Tomurcuklanan maya hücreleri ve psödohif yapıları izlendi. // Candida enfeksiyonunu destekler.

Tetkik 2: Germ tüp testi

Etiket: Germ tüp testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Candida albicans lehinedir. | Sonuç yorumu: Candida albicans lehinedir. | Sonuç başlığı: Germ tüp testi | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Candida albicans lehinedir. | Satırlar: Germ tüp testi / Pozitif saptandı. // Candida albicans lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Candida albicans
B) Aspergillus fumigatus
C) Cryptococcus neoformans
D) Microsporum canis
E) Pneumocystis jirovecii

Doğru Cevap: Candida albicans

- A) Candida albicans: Candida albicans silinebilir oral plak, psödohif ve pozitif germ tüp testiyle en uyumlu etkidir. Vakadaki "Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır." ve "Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Aspergillus fumigatus: Aspergillus fumigatus septalı hiflerle invaziv akciğer enfeksiyonu yapabilir; oral psödohifli plak için tipik değildir. Bu olguda "Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır." ve "Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Candida albicans seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Cryptococcus neoformans: Vakadaki Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır ve Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir. Bu olguda "Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır." ve "Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Candida albicans seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Microsporum canis: Microsporum canis dermatofit enfeksiyonlarıyla ilişkilidir; oral kandidiyazis paternini açıklamaz. Bu olguda "Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır." ve "Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Candida albicans seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Pneumocystis jirovecii: Pneumocystis jirovecii immünsüprese hastalarda pnömoni yapar; oral silinebilir plak ve germ tüp testiyle uyumlu değildir. Bu olguda "Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır." ve "Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Candida albicans seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antibiyotik sonrası oral plaklar olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır." ve "Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir." birlikte okunduğunda Candida albicans seçeneği öne çıkar; "KOH incelemesinde psödohifler ve germ tüp testi pozitifliği saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Antibiyotik kullanımı ve diyabet zemininde silinebilir oral beyaz plaklar kandidiyazisi düşündürür. KOH incelemesinde maya ve psödohif görülmesi, germ tüp testinin pozitif olması Candida albicans lehinedir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır.", "Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir." ve "KOH incelemesinde psödohifler ve germ tüp testi pozitifliği saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Candida albicans en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada antibiyotik kullanımı ve diyabet öyküsü vardır.

Kanıt 2: Oral mukozada silinebilir beyaz plaklar izlenmiştir.

Kanıt 3: KOH incelemesinde psödohifler ve germ tüp testi pozitifliği saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Candida albicans germ tüp testi pozitifliği ve psödohif oluşumuyla tanınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 285: v189-new-285-akintisiz-dizuri-ve-uretrit

Başlık: Akıntısız dizüri ve üretrit

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla ilişkilendirme.

Learning Target: Chlamydia trachomatis üretritinde hücre içi bakteri ve NAAT tanısını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, dizüri ve hafif üretral rahatsızlık nedeniyle başvuruyor. Korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır. Belirgin pürülan akıntı tariflememekte, ancak sabahları hafif berrak akıntı fark ettiğini söylemektedir.

Demografi: 22 yaşında erkek hasta | Setting: üroloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Üretral meatus hafif eritemlidir.
- Testislerde hassasiyet yoktur.
- Ateş saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar nükleik asit amplifikasyon testi

Etiket: İdrar nükleik asit amplifikasyon testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Chlamydia trachomatis pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni doğrular. | Sonuç yorumu: Etkeni doğrular. | Sonuç başlığı: İdrar nükleik asit amplifikasyon testi | Sonuç özeti: Chlamydia trachomatis pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni doğrular. | Satırlar: İdrar nükleik asit amplifikasyon testi / Chlamydia trachomatis pozitif saptandı. // Etkeni doğrular.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Chlamydia trachomatis
B) Treponema pallidum
C) Haemophilus ducreyi
D) Klebsiella granulomatis
E) Trichomonas vaginalis

Doğru Cevap: Chlamydia trachomatis

A) Chlamydia trachomatis: Chlamydia trachomatis hafif akıntılı nongonokokal üretrit ve pozitif NAAT bulgusuyla en uyumlu etkidir. Vakadaki “Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.” ve “Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Treponema pallidum: Treponema pallidum ağrısız şankr ve sistemik sifiliz bulgularıyla ilişkilidir; bu üretrit paternini açıklamaz. Bu olguda “Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.” ve “Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Chlamydia trachomatis seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Haemophilus ducreyi: Haemophilus ducreyi ağrılı genital ülser ve hassas lenfadenopati yapar; hafif üretrit için tipik değildir. Bu olguda “Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.” ve “Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Chlamydia trachomatis seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Klebsiella granulomatis: Klebsiella granulomatis donovanozda kanamalı ülseratif lezyon yapar; NAAT pozitif üretrit etkeni değildir. Bu olguda “Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.” ve “Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Chlamydia trachomatis seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Trichomonas vaginalis: Trichomonas vaginalis üretrit yapabilir ancak verilen test sonucu ve tipik nongonokokal üretrit bağlamı Chlamydia lehinedir. Bu olguda “Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.” ve “Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Chlamydia trachomatis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Akıntısız dizüri ve üretrit olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.” ve “Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.” birlikte okunduğunda Chlamydia trachomatis seçeneği öne çıkar; “NAAT testi Chlamydia trachomatis pozitif saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Genç erkekte korunmasız cinsel ilişki sonrası dizüri ve hafif berrak akıntıyla seyreden nongonokokal üretrit en sık nedenlerinden biri Chlamydia trachomatis'tir. Tanıda nükleik asit amplifikasyon testleri duyarlıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.”, “Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.” ve “NAAT testi Chlamydia trachomatis pozitif saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Chlamydia trachomatis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada korunmasız cinsel ilişki öyküsü vardır.

Kanıt 2: Dizüri ve hafif berrak üretral akıntı tariflenmiştir.

Kanıt 3: NAAT testi Chlamydia trachomatis pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Chlamydia trachomatis nongonokokal üretrit en sık nedenidir ve NAAT ile tanınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 286: v189-new-286-kronik-inflamasyon-sonrasi-proteinuri

Başlık: Kronik inflamasyon sonrası proteinüri

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik paterni klinik tabloyla ilişkilendirme.

Learning Target: Amiloidozda Kongo kırmızısı boyanması ve elma yeşili çift kırılma tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacaklarda şişlik ve köpüklü idrar nedeniyle başvuruyor. Uzun yıllardır kontrolsüz romatoid artrit tanısı olduğu öğreniliyor. Son aylarda ödem ve halsizlik gelişmiştir.

Demografi: 56 yaşında erkek hasta | Setting: nefroloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 136/82 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,62

Fizik Muayene

- Bilateral pretibial ödem vardır.
- Eklemler deformiteleri izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: 24 saatlik idrar protein düzeyi

Etiket: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Klinik anlam: Glomerüler protein kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Glomerüler protein kaybını destekler. | Sonuç başlığı: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Sonuç özeti: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Yorum: Glomerüler protein kaybını destekler. | Satırlar: 24 saatlik idrar protein düzeyi / Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. / 5.8 g/gün / <0.15 g/gün

Tetkik 2: Böbrek biyopsisi özel boyama

Etiket: Böbrek biyopsisi özel boyama | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Kongo kırmızısı ile boyanan birikimler polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılma gösterdi. | Klinik anlam: Amiloid birikimi için karakteristiktir. | Sonuç yorumu: Amiloid birikimi için karakteristiktir. | Sonuç başlığı: Böbrek biyopsisi özel boyama | Sonuç özeti: Kongo kırmızısı ile boyanan birikimler polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılma gösterdi. | Yorum: Amiloid birikimi için karakteristiktir. | Satırlar: Böbrek biyopsisi özel boyama / Kongo kırmızısı ile boyanan birikimler polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılma gösterdi. / / Amiloid birikimi için karakteristiktir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-142 | Başlık: Böbrek biyopsisi özel boyama | Modalite: microscopy | Bulgu: Kongo kırmızısı ile boyanan birikimler polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılma gösterdi. | Klinik anlam: Amiloid birikimi için karakteristiktir. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/142_amiloidoz_kongo_kirmizisi_polarizan_mikroskopi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/142_amiloidoz_kongo_kirmizisi_polarizan_mikroskopi.webp | Alt text: Böbrek biyopsisi özel boyama - Kongo kırmızısı ile boyanan birikimler polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılma gösterdi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada böbrekte biriken materyal için en karakteristik histokimyasal bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma
B) Gram boyamada gram-negatif diplokok
C) Ziehl-Neelsen ile aside dirençli basil
D) PAS negatif tamamen boş glomerüller
E) Masson trikrom ile yalnız kalsifikasyon

Doğru Cevap: Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma

- A) Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma: Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma amiloid birikimi için karakteristik histokimyasal bulgudur. Vakadaki "Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır." ve "Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Gram boyamada gram-negatif diplokok: Gram-negatif diplokok bakteriyel enfeksiyon tanımlamak için kullanılır; amiloid materyali göstermez. Bu olguda "Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır." ve "Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir." ipuçları klinik karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ziehl-Neelsen ile aside dirençli basil: Aside dirençli basil tüberküloz gibi mikobakteriyel enfeksiyonları gösterir; amiloidozun karakteristik boyası değildir. Bu olguda "Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır." ve "Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir." ipuçları klinik karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) PAS negatif tamamen boş glomerüller: Vakadaki Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır ve Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir. Bu olguda "Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır." ve "Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir." ipuçları klinik karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Masson trikrom ile yalnız kalsifikasyon: Masson trikrom kollajen/fibrozis değerlendirmesinde kullanılır; amiloid için klasik elma yeşili çift kırılma bulgusunu vermez. Bu olguda "Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır." ve "Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir." ipuçları klinik karar açısından Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kronik inflamasyon sonrası proteinüri olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır." ve "Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir." birlikte okunduğunda Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma seçeneği öne çıkar; "Biyopside Kongo kırmızısı pozitif birikimler tanımlanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik inflamatuvar hastalık zemininde nefrotik proteinüri ve böbrekte amiloid birikimi sekonder amiloidozu düşündürür. Amiloid Kongo kırmızısı ile boyanır ve polarize ışıktaki elma yeşili çift kırılma gösterir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır.", "Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir." ve "Biyopside Kongo kırmızısı pozitif birikimler tanımlanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kongo kırmızısı ile elma yeşili çift kırılma en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada uzun süreli romatoid artrit öyküsü vardır.

Kanıt 2: Nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem gelişmiştir.

Kanıt 3: Biyopside Kongo kırmızısı pozitif birikimler tanımlanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Amiloid birikimi Kongo kırmızısı boyası ve elma yeşili çift kırılma ile tanınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 287: v189-new-287-uzun-suren-gastrit-sonrasi-metaplazi

Başlık: Uzun süren gastrit sonrası metaplazi

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik paterni klinik tabloyla ilişkilendirme.

Learning Target: Kronik gastritte intestinal tip mide adenokarsinomu riskini atrofi ve intestinal metaplaziyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kronik dispepsi nedeniyle yapılan endoskopik biyopsi sonucuyla başvuruyor. Yıllardır epigastrik rahatsızlık ve erken doyma yakınması olduğunu belirtmektedir. Daha önce Helicobacter pylori enfeksiyonu saptanmış ancak tedavisini tamamlamamıştır.

Demografi: 62 yaşında erkek hasta | Setting: gastroenteroloji polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fizik muayenede akut batın bulgusu yoktur.
- Hafif kilo kaybı tariflemektedir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Mide biyopsisi

Etiket: Mide biyopsisi | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Kronik aktif gastrit, glandüler atrofi ve intestinal metaplazi izlendi. | Klinik anlam: Karsinogenez açısından riskli zemin oluşturur. | Sonuç yorumu: Karsinogenez açısından riskli zemin oluşturur. | Sonuç başlığı: Mide biyopsisi | Sonuç özeti: Kronik aktif gastrit, glandüler atrofi ve intestinal metaplazi izlendi. | Yorum: Karsinogenez açısından riskli zemin oluşturur. | Satırlar: Mide biyopsisi / Kronik aktif gastrit, glandüler atrofi ve intestinal metaplazi izlendi. // Karsinogenez açısından riskli zemin oluşturur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-143 | Başlık: Mide biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Kronik aktif gastrit, glandüler atrofi ve intestinal metaplazi izlendi. | Klinik anlam: Karsinogenez açısından riskli zemin oluşturur. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/143_kronik_gastrit_intestinal_metaplazi_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/143_kronik_gastrit_intestinal_metaplazi_histopatoloji.webp | Alt text: Mide biyopsisi - Kronik aktif gastrit, glandüler atrofi ve intestinal metaplazi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu histolojik zemin en çok hangi malignite riskini artırır?

- A) İntestinal tip mide adenokarsinomu
B) Hepatoselüler karsinom
C) Papiller tiroid karsinomu
D) Renal hücreli karsinom
E) Osteosarkom

Doğru Cevap: İntestinal tip mide adenokarsinomu

- A) İntestinal tip mide adenokarsinomu: İntestinal tip mide adenokarsinomu kronik gastrit, atrofi ve intestinal metaplazi zemininde gelişme riski artan malignitedir. Vakadaki “Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.” ve “Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Hepatoselüler karsinom: Hepatoselüler karsinom kronik hepatit ve sirozla ilişkilidir; mide intestinal metaplazisiyle açıklanmaz. Bu olguda “Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.” ve “Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından İntestinal tip mide adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Papiller tiroid karsinomu: Papiller tiroid karsinomu tiroid folliküler epitelinden gelişir; gastrik metaplaziyle ilişkili değildir. Bu olguda “Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.” ve “Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından İntestinal tip mide adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Renal hücreli karsinom: Renal hücreli karsinom böbrek parankiminden kaynaklanır; mide biyopsi bulguları riskini doğrudan artırmaz. Bu olguda “Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.” ve “Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından İntestinal tip mide adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Osteosarkom: Vakadaki Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır ve Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir. Bu olguda “Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.” ve “Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından İntestinal tip mide adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzun süren gastrit sonrası metaplazi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.” ve “Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.” birlikte okunduğunda İntestinal tip mide adenokarsinomu seçeneği öne çıkar; “Biyopside intestinal metaplazi izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik Helicobacter pylori ilişkili gastrit, glandüler atrofi ve intestinal metaplazi intestinal tip mide adenokarsinomu gelişim riskini artırır. Bu süreç Correa kaskadı olarak tanımlanan çok basamaklı karsinogenezle ilişkilidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.”, “Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.” ve “Biyopside intestinal metaplazi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntestinal tip mide adenokarsinomu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada tedavisi tamamlanmamış Helicobacter pylori öyküsü vardır.

Kanıt 2: Biyopside kronik aktif gastrit ve glandüler atrofi gösterilmiştir.

Kanıt 3: Biyopside intestinal metaplazi izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Kronik atrofik gastrit ve intestinal metaplazi intestinal tip mide adenokarsinomu riskini artırır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 288: v189-new-288-sigara-icen-hastada-hiponatremi

Başlık: Sigara içen hastada hiponatremi

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik paterni klinik tabloyla ilişkilendirme.

Learning Target: Küçük hücreli akciğer karsinomunda nöroendokrin özellik ve paraneoplastik ADH üretimini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, öksürük, kilo kaybı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle başvuruyor. Yoğun sigara öyküsü vardır. Son iki ayda kilo kaybı, iştahsızlık ve giderek artan öksürük gelişmiştir. Son günlerde baş ağrısı ve dalgınlık eklenmiştir.

Demografi: 64 yaşında erkek hasta | Setting: göğüs hastalıkları polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta zayıf ve halsiz görünmektedir.
- Akciğer sağ üst alanda solunum sesleri azalmıştır.
- Hafif konfüzyon vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Uygunsuz ADH salgısı olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Uygunsuz ADH salgısı olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Uygunsuz ADH salgısı olasılığını destekler. | Satırlar: Serum sodyum / Düşük saptandı. / 121 mmol/L / 135-145 mmol/L

Tetkik 2: Bronkoskopik biyopsi

Etiket: Bronkoskopik biyopsi | Tip: pathology | Alt tip: Patoloji | Özet: Dar sitoplazmalı küçük hiperkromatik hücrelerden oluşan nöroendokrin tümör izlendi. | Klinik anlam: Küçük hücreli akciğer karsinomu lehinedir. | Sonuç yorumu: Küçük hücreli akciğer karsinomu lehinedir. | Sonuç başlığı: Bronkoskopik biyopsi | Sonuç özeti: Dar sitoplazmalı küçük hiperkromatik hücrelerden oluşan nöroendokrin tümör izlendi. | Yorum: Küçük hücreli akciğer karsinomu lehinedir. | Satırlar: Bronkoskopik biyopsi / Dar sitoplazmalı küçük hiperkromatik hücrelerden oluşan nöroendokrin tümör izlendi. / / Küçük hücreli akciğer karsinomu lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-144 | Başlık: Bronkoskopik biyopsi | Modalite: microscopy | Bulgu: Dar sitoplazmalı küçük hiperkromatik hücrelerden oluşan nöroendokrin tümör izlendi. | Klinik anlam: Küçük hücreli akciğer karsinomu lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/144_kucuk_hucrel_i_kciger_karsinomu_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/144_kucuk_hucrel_i_kciger_karsinomu_histopatoloji.webp | Alt text: Bronkoskopik biyopsi - Dar sitoplazmalı küçük hiperkromatik hücrelerden oluşan nöroendokrin tümör izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tümörde hiponatreminin en olası paraneoplastik mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ektopik antidiüretik hormon salgısı
B) Ektopik eritropoietin salgısı
C) Paratiroid hormon benzeri peptid salgısı
D) İnsülin reseptör blokajı
E) Aldosteron yıkımının artması

Doğru Cevap: Ektopik antidiüretik hormon salgısı

- A) Ektopik antidiüretik hormon salgısı: Ektopik antidiüretik hormon salgısı küçük hücreli akciğer karsinomunda hiponatremi ve konfüzyonu açıklar. Vakadaki “Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.” ve “Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Ektopik eritropoietin salgısı: Vakadaki Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır ve Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır. Bu olguda “Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.” ve “Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Ektopik antidiüretik hormon salgısı seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Paratiroid hormon benzeri peptid salgısı: Paratiroid hormon benzeri peptid salgısı hiperkalsemi yapar ve daha çok skuamöz hücreli akciğer karsinomunda beklenir. Bu olguda “Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.” ve “Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Ektopik antidiüretik hormon salgısı seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) İnsülin reseptör blokajı: Vakadaki Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır ve Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır. Bu olguda “Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.” ve “Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Ektopik antidiüretik hormon salgısı seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Aldosteron yıkımının artması: Vakadaki Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır ve Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır. Bu olguda “Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.” ve “Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Ektopik antidiüretik hormon salgısı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sigara içen hastada hiponatremi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.” ve “Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.” birlikte okunduğunda Ektopik antidiüretik hormon salgısı seçeneği öne çıkar; “Serum sodyumu belirgin düşüktür ve bilinç bulanıklığı vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Küçük hücreli akciğer karsinomu nöroendokrin özellik gösterir ve paraneoplastik hormon salgılayabilir. Hiponatremi, düşük serum sodyumu ve nörolojik semptomlar uygunsuz ADH salgısını düşündürür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.”, “Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.” ve “Serum sodyumu belirgin düşüktür ve bilinç bulanıklığı vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ektopik antidiüretik hormon salgısı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada yoğun sigara öyküsü ve akciğer kitlesi vardır.

Kanıt 2: Biyopside küçük hücreli nöroendokrin tümör tanımlanmıştır.

Kanıt 3: Serum sodyumu belirgin düşüktür ve bilinç bulanıklığı vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Küçük hücreli akciğer karsinomu SIADH ve Cushing sendromu gibi paraneoplastik tablolar yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 289: v189-new-289-agri-kesici-asiri-alimi

Başlık: Ağrı kesici aşırı alımı

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Parasetamol toksisitesinde N-asetilsistein tedavisini glutatyon yenilenmesiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, çok sayıda parasetamol tableti aldıktan sonra bulantı ve karın rahatsızlığı nedeniyle getiriliyor. Yaklaşık 6 saat önce yüksek doz parasetamol aldığı öğreniliyor. Alkol kullanımı yoktur ancak ne kadar tablet aldığı net değildir.

Demografi: 19 yaşında kadın hasta | Setting: acil serviste değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Epigastrik bölgede hafif hassasiyet vardır.
- Bilinci açıktır.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum parasetamol düzeyi

Etiket: Serum parasetamol düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksikite riski taşıyan düzeyde saptandı. | Klinik anlam: Antidot tedavisi gereksinimini destekler. | Sonuç yorumu: Antidot tedavisi gereksinimini destekler. | Sonuç başlığı: Serum parasetamol düzeyi | Sonuç özeti: Toksikite riski taşıyan düzeyde saptandı. | Yorum: Antidot tedavisi gereksinimini destekler. | Satırlar: Serum parasetamol düzeyi / Toksikite riski taşıyan düzeyde saptandı. // Antidot tedavisi gereksinimini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada başlanması gereken antidot aşağıdakilerden hangisidir?

- A) N-asetilsistein
B) Flumazenil
C) Nalokson
D) Protamin sülfat
E) Atropin

Doğru Cevap: N-asetilsistein

- A) N-asetilsistein: N-asetilsistein glutatyon depolarını yenileyerek parasetamol toksik metabolitinin detoksifikasyonunu sağlar. Vakadaki "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Flumazenil: Flumazenil benzodiazepin antagonist olarak kullanılır; parasetamol hepatotoksitesini önlemez. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nalokson: Nalokson opioid toksisitesinde solunum depresyonunu geri çevirir; parasetamol antidotu değildir. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Protamin sülfat: Vakadaki Hasta yüksek doz parasetamol almıştır ve Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Atropin: Atropin muskarinik toksisite veya bradikardi durumlarında kullanılır; parasetamol toksisitesi için uygun değildir. Bu olguda "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından N-asetilsistein seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ağrı kesici aşırı alımı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır." ve "Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır." birlikte okunduğunda N-asetilsistein seçeneği öne çıkar; "Serum parasetamol düzeyi riskli bulunmuştur." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Parasetamol aşırı alımında toksik metabolit NAPQI glutatyon depoları tükenince hepatoselüler hasar oluşturur. N-asetilsistein glutatyon öncülü olarak NAPQI detoksifikasyonunu artırır ve hepatotoksiteyi azaltır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta yüksek doz parasetamol almıştır.", "Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır." ve "Serum parasetamol düzeyi riskli bulunmuştur." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle N-asetilsistein en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta yüksek doz parasetamol almıştır.

Kanıt 2: Alım zamanı erken dönemdedir ve toksisite riski vardır.

Kanıt 3: Serum parasetamol düzeyi riskli bulunmuştur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Parasetamol toksisitesinde antidot N-asetilsisteindir ve en etkilisi erken verilmesidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 290: v189-new-290-heparin-sonrasi-trombosit-dususu-ve-bacak-agrisi

Başlık: Heparin sonrası trombosit düşüşü ve bacak ağrısı

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Heparine bağlı trombositopenide tromboz riskini ve heparinin kesilmesini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, heparin tedavisinin altıncı gününde trombosit düşüşü ve yeni gelişen bacak ağrısı nedeniyle inceleniyor. Derin ven trombozu profilaksisi için unfractionated heparin aldığı öğreniliyor. Son 24 saatte sağ baldırda ağrı ve şişlik gelişmiştir.

Demografi: 62 yaşında erkek hasta | Setting: hastanede yatarken hematoloji tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 124/76 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,74

Fizik Muayene

- Sağ baldırda hassasiyet ve çevre artışı vardır.
- Petesi belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Başlangıca göre yüzde 50'den fazla düşüş saptandı. | Klinik anlam: Heparine bağlı trombositopeni açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Heparine bağlı trombositopeni açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Başlangıca göre yüzde 50'den fazla düşüş saptandı. | Yorum: Heparine bağlı trombositopeni açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Trombosit sayısı / Başlangıca göre yüzde 50'den fazla düşüş saptandı. / 82000 /mm³ / 150000-450000 /mm³

Tetkik 2: Venöz Doppler ultrasonografi

Etiket: Venöz Doppler ultrasonografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ popliteal vende trombüs izlendi. | Klinik anlam: Trombotik komplikasyonu gösterir. | Sonuç yorumu: Trombotik komplikasyonu gösterir. | Sonuç başlığı: Venöz Doppler ultrasonografi | Sonuç özeti: Sağ popliteal vende trombüs izlendi. | Yorum: Trombotik komplikasyonu gösterir. | Satırlar: Venöz Doppler ultrasonografi / Sağ popliteal vende trombüs izlendi. / / Trombotik komplikasyonu gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-145 | Başlık: Venöz Doppler ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sağ popliteal vende trombüs izlendi. | Klinik anlam: Trombotik komplikasyonu gösterir. | URL: https://iukbtlkzixictqsds.public.blob.vercel-storage.com/145_popliteal_ven_trombozu_doppler_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqsds.public.blob.vercel-storage.com/145_popliteal_ven_trombozu_doppler_usg.webp | Alt text: Venöz Doppler ultrasonografi - Sağ popliteal vende trombüs izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak
- B) Heparin dozunu artırmak
- C) Trombosit transfüzyonu yapıp heparine devam etmek
- D) Varfarini tek başına hemen başlamak
- E) Heparini kesip antikoagülasyonu trombositler normale dönene kadar tamamen durdurmak

Doğru Cevap: Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak

- A) Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak: Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak HIT tip II'de tromboz riskini yönetmek için doğru yaklaşımdır. Vakadaki "Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir." ve "Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Heparin dozunu artırmak: Vakadaki Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir ve Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır. Bu olguda "Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir." ve "Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Trombosit transfüzyonu yapıp heparine devam etmek: Vakadaki Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir ve Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır. Bu olguda "Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir." ve "Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Varfarini tek başına hemen başlamak: Varfarini tek başına hemen başlamak erken dönemde protein C düşüşü nedeniyle trombozu kötüleştirebilir. Bu olguda "Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir." ve "Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Heparini kesip antikoagülasyonu trombositler normale dönene kadar tamamen durdurmak: Vakadaki Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir ve Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır. Bu olguda "Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir." ve "Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Heparin sonrası trombosit düşüşü ve bacak ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir." ve "Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır." birlikte okunduğunda Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak seçeneği öne çıkar; "Yeni popliteal ven trombozu saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Heparin başlangıcından 5-10 gün sonra trombositlerde belirgin düşüş ve yeni tromboz gelişmesi heparine bağlı trombositopeni tip II düşündürür. Heparin hemen kesilmesi ve argatroban gibi heparin dışı antikoagülan başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir.", "Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır." ve "Yeni popliteal ven trombozu saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Heparini kesip heparin dışı antikoagülan başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Trombosit düşüşü heparin tedavisinin altıncı gününde gelişmiştir.

Kanıt 2: Trombosit sayısı başlangıca göre belirgin azalmıştır.

Kanıt 3: Yeni popliteal ven trombozu saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: HIT kanama değil tromboz riski taşır; heparin kesilir ve heparin dışı antikoagülasyon başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 291: v189-new-291-vagal-bradikardi-atagi

Başlık: Vagal bradikardi atağı

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Atropinin muskarinik reseptör blokajını bradikardi tedavisiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ani baş dönmesi ve bayılacak gibi olma hissi sırasında belirgin bradikardi saptanması nedeniyle izleniyor. Daha önce benzer ataklarının ağrı ve bulantı sırasında geliştiğini belirtmektedir. Beta bloker kullanımı yoktur.

Demografi: 55 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/52 mmHg | Nabız: 38/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,44

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve terli görünmektedir.
- Akciğer muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sinüs bradikardisi izlendi. | Klinik anlam: Vagal tonus artışıyla uyumlu olabilir. | Sonuç yorumu: Vagal tonus artışıyla uyumlu olabilir. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Sinüs bradikardisi izlendi. | Yorum: Vagal tonus artışıyla uyumlu olabilir. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Sinüs bradikardisi izlendi. // Vagal tonus artışıyla uyumlu olabilir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-146 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Sinüs bradikardisi izlendi. | Klinik anlam: Vagal tonus artışıyla uyumlu olabilir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/146_sinus_bradikardisi_ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/146_sinus_bradikardisi_ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Sinüs bradikardisi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada atropinin kalp hızını artırma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi
B) Beta-1 reseptörleri irreversibl bloke etmesi
C) Nikotinik reseptörleri sürekli aktive etmesi
D) Adenozin reseptörlerini aktive etmesi
E) Potasyum kanallarını kalıcı açması

Doğru Cevap: Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi

A) Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi: Muskarinik M2 reseptör blokajı atropinin vagal bradikardide kalp hızını artıran temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.” ve “Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Beta-1 reseptörleri irreversibl bloke etmesi: Vakadaki Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır ve Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir. Bu olguda “Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.” ve “Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Nikotinik reseptörleri sürekli aktive etmesi: Vakadaki Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır ve Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir. Bu olguda “Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.” ve “Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Adenozin reseptörlerini aktive etmesi: Adenozin reseptör aktivasyonu atriyoventriküler iletimi yavaşlatır; bradikardiyi düzeltен mekanizma değildir. Bu olguda “Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.” ve “Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Potasyum kanallarını kalıcı açması: Potasyum kanallarını kalıcı açmak hücreleri hiperpolarize edebilir; atropinin klinik etkisiyle uyumlu değildir. Bu olguda “Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.” ve “Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Vagal bradikardi atağı olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.” ve “Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi seçeneği öne çıkar; “Beta bloker kullanımı belirtilmemiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Atropin parasempatik muskarinik reseptörleri bloke eden antimuskarinik bir ilaçtır. Kalpte M2 reseptör blokajı vagal etkiyi azaltır, sinoatriyal düğüm aktivitesi artar ve kalp hızı yükselir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.”, “Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.” ve “Beta bloker kullanımı belirtilmemiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Muskarinik M2 reseptörleri bloke etmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada semptomatik sinüs bradikardisi vardır.

Kanıt 2: Atak vagal tonus artışıyla uyumlu klinik bağlamda gelişmiştir.

Kanıt 3: Beta bloker kullanımı belirtilmemiştir.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Atropin kalpte M2 muskarinik reseptör blokajıyla vagal bradikardiyi düzeltir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 292: v189-new-292-cilt-enfeksiyonunda-orantisiz-agri

Başlık: Cilt enfeksiyonunda orantisiz ağrı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Nekrotizan fasiitte hızlı ilerleyen ağrı ve sistemik toksisiteyle acil debridman gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ bacadaki hızla artan ağrı, şişlik ve ateş nedeniyle başvuruyor. Diyabet öyküsü vardır. İki gün önce bacağına küçük bir kesi oluştuğunu, son 12 saatte ağrının çok şiddetlendiğini ve yayıldığını belirtmektedir.

Demografi: 49 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste genel cerrahi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 39.0°C | Şok indeksi: 1,50 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ bacadaki eritem, ödem ve palpasyonla krepitasyon vardır.
- Ağrı cilt bulgusuna göre belirgin fazladır.
- Hasta toksik görünümündedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum laktat

Etiket: Serum laktat | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Doku hipoperfüzyonu ve ağır enfeksiyonu destekler. | Sonuç yorumu: Doku hipoperfüzyonu ve ağır enfeksiyonu destekler. | Sonuç başlığı: Serum laktat | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Doku hipoperfüzyonu ve ağır enfeksiyonu destekler. | Satırlar: Serum laktat / Yüksek saptandı. / 4.8 mmol/L / 0.5-2.2 mmol/L

Tetkik 2: Yumuşak doku grafisi

Etiket: Yumuşak doku grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ bacak yumuşak dokusunda gaz gölgeleri izlendi. | Klinik anlam: Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Yumuşak doku grafisi | Sonuç özeti: Sağ bacak yumuşak dokusunda gaz gölgeleri izlendi. | Yorum: Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Yumuşak doku grafisi / Sağ bacak yumuşak dokusunda gaz gölgeleri izlendi. / Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu açısından uyarıcıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-147 | Başlık: Yumuşak doku grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ bacak yumuşak dokusunda gaz gölgeleri izlendi. | Klinik anlam: Nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu açısından uyarıcıdır. | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/147_nekrotizan_enfeksiyon_yumusak_doku_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/147_nekrotizan_enfeksiyon_yumusak_doku_grafisi.webp | Alt text: Yumuşak doku grafisi - Sağ bacak yumuşak dokusunda gaz gölgeleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman
- B) Oral antibiyotikle ayakta izlem
- C) Ağrı kesici verip 48 saat sonra kontrol
- D) Lokal steroidli krem başlamak
- E) İleri görüntüleme ve kültür sonuçlarını bekleyerek debridman kararını ertelemek

Doğru Cevap: Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman

A) Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman: Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman nekrotizan fasiitte doğru ve hayat kurtarıcı yaklaşımdır. Vakadaki “Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Oral antibiyotikle ayakta izlem: Vakadaki Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir ve Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır. Bu olguda “Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Ağrı kesici verip 48 saat sonra kontrol: Vakadaki Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir ve Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır. Bu olguda “Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Lokal steroidli krem başlamak: Vakadaki Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir ve Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır. Bu olguda “Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

E) İleri görüntüleme ve kültür sonuçlarını bekleyerek debridman kararını ertelemek: Vakadaki Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir ve Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır. Bu olguda “Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Cilt enfeksiyonunda orantisiz ağrı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.” ve “Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır.” birlikte okunduğunda Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman seçeneği öne çıkar; “Krepitasyon ve yumuşak dokuda gaz saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Orantisiz şiddetli ağrı, hızlı ilerleme, sistemik toksisite, krepitasyon ve yumuşak dokuda gaz nekrotizan fasiiti düşündürür. Tedavi antibiyotikle sınırlı değildir; kaynak kontrolü için acil cerrahi debridman gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.”, “Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır.” ve “Krepitasyon ve yumuşak dokuda gaz saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Geniş spektrumlu antibiyotik ve acil cerrahi debridman en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Diyabetik hastada küçük kesi sonrası hızlı ilerleyen enfeksiyon gelişmiştir.

Kanıt 2: Ağrı cilt bulgularına göre belirgin fazladır.

Kanıt 3: Krepitasyon ve yumuşak dokuda gaz saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Nekrotizan fasiitte antibiyotik şarttır ama cerrahi debridman gecikirse mortalite artar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 293: v189-new-293-karin-sisligi-ve-gaz-cikaramama

Başlık: Karın şişliği ve gaz çıkaramama

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Sigmoid volvulus'ta kahve çekirdeği görünümü ve endoskopik detorsiyon yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, karında belirgin şişlik, kabızlık ve gaz çıkaramama nedeniyle başvuruyor. Uzun süredir kabızlık yaşadığı, son iki gündür dışkı ve gaz çıkaramadığı öğreniliyor. Şiddetli sürekli ağrı veya kanlı dışkı tariflememektedir.

Demografi: 76 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste genel cerrahi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 37.2°C | Şok indeksi: 0,81

Fizik Muayene

- Batın belirgin distandüdü ancak yaygın peritonit bulgusu yoktur.
- Rektal tuşe boş ampulla ile uyumludur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ayakta direkt karın grafisi

Etiket: Ayakta direkt karın grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol alt kadrandan sağ üst kadrana uzanan kahve çekirdeği görünümü izlendi. | Klinik anlam: Sigmoid volvulus lehinedir. | Sonuç yorumu: Sigmoid volvulus lehinedir. | Sonuç başlığı: Ayakta direkt karın grafisi | Sonuç özeti: Sol alt kadrandan sağ üst kadrana uzanan kahve çekirdeği görünümü izlendi. | Yorum: Sigmoid volvulus lehinedir. | Satırlar: Ayakta direkt karın grafisi / Sol alt kadrandan sağ üst kadrana uzanan kahve çekirdeği görünümü izlendi. // Sigmoid volvulus lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-148 | Başlık: Ayakta direkt karın grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sol alt kadrandan sağ üst kadrana uzanan kahve çekirdeği görünümü izlendi. | Klinik anlam: Sigmoid volvulus lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/148_sigmoid_volvulus_kahve_cekirdegi_grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/148_sigmoid_volvulus_kahve_cekirdegi_grafi.webp | Alt text: Ayakta direkt karın grafisi - Sol alt kadrandan sağ üst kadrana uzanan kahve çekirdeği görünümü izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Peritonit bulgusu olmayan bu hastada en uygun başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon
- B) Laksatif tedaviyle ayaktan izlem
- C) Acil total gastrektomi
- D) Nazogastrik dekompresyon ve konservatif izlemle endoskopik detorsiyonu ertelemek
- E) Kolonoskopi olmadan uzun süre izlem planlamak

Doğru Cevap: Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon

A) Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon: Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon peritonit bulgusu olmayan sigmoid volvulus'ta uygun başlangıç tedavisidir. Vakadaki "Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır." ve "Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Laksatif tedaviyle ayaktan izlem: Vakadaki Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır ve Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir. Bu olguda "Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır." ve "Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Acil total gastrektomi: Vakadaki Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır ve Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir. Bu olguda "Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır." ve "Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nazogastrik dekompresyon ve konservatif izlemle endoskopik detorsiyonu ertelemek: Vakadaki Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır ve Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir. Bu olguda "Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır." ve "Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kolonoskopi olmadan uzun süre izlem planlamak: Vakadaki Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır ve Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir. Bu olguda "Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır." ve "Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir." ipuçları tedavi önceliği açısından Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Karın şişliği ve gaz çıkaramama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır." ve "Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir." birlikte okunduğunda Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon seçeneği öne çıkar; "Muayenede yaygın peritonit bulgusu yoktur." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sigmoid volvulus'ta karın distansiyonu, kabızlık, gaz çıkaramama ve kahve çekirdeği görünümü tipiktir. Peritonit veya iskemi yoksa başlangıç tedavisi endoskopik detorsiyondur; perforasyon veya peritonit varsa cerrahi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır.", "Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir." ve "Muayenede yaygın peritonit bulgusu yoktur." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Fleksibl sigmoidoskopi ile endoskopik detorsiyon en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada kabızlık, distansiyon ve gaz çıkaramama vardır.

Kanıt 2: Grafide kahve çekirdeği görünümü izlenmiştir.

Kanıt 3: Muayenede yaygın peritonit bulgusu yoktur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Sigmoid volvulus'ta peritonit yoksa ilk yaklaşım endoskopik detorsiyondur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 294: v189-new-294-supheli-tiroid-nodulu

Başlık: Şüpheli tiroid nodülü

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanısal yaklaşımı klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Tiroid nodülünde malignite şüphesinde ince iğne aspirasyon biyopsisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, boynun ön kısmında fark ettiği tiroid nodülü nedeniyle başvuruyor. Nodülü son aylarda fark ettiğini, ailesinde tiroid kanseri öyküsü olduğunu ve çocukluk döneminde baş-boyun bölgesine radyasyon aldığını belirtmektedir.

Demografi: 39 yaşında kadın hasta | Setting: genel cerrahi polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Tiroid sağ lobda sert, sınırları düzensiz, yaklaşık 1.5 cm nodül palpe edilir.
- Servikal bölgede küçük lenf nodları vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tiroid ultrasonografisi

Etiket: Tiroid ultrasonografisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Hipoekoik, mikrokalsifikasyon içeren, düzensiz sınırlı solid nodül izlendi. | Klinik anlam: Malignite şüphesini artıran özellikler taşır. | Sonuç yorumu: Malignite şüphesini artıran özellikler taşır. | Sonuç başlığı: Tiroid ultrasonografisi | Sonuç özeti: Hipoekoik, mikrokalsifikasyon içeren, düzensiz sınırlı solid nodül izlendi. | Yorum: Malignite şüphesini artıran özellikler taşır. | Satırlar: Tiroid ultrasonografisi / Hipoekoik, mikrokalsifikasyon içeren, düzensiz sınırlı solid nodül izlendi. / 1.6 cm / Malignite şüphesini artıran özellikler taşır.

Tetkik 2: TSH

Etiket: TSH | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Fonksiyonel değerlendirmeyi destekler. | Sonuç yorumu: Fonksiyonel değerlendirmeyi destekler. | Sonuç başlığı: TSH | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Fonksiyonel değerlendirmeyi destekler. | Satırlar: TSH / Normal saptandı. / 1.8 mIU/L / 0.4-4.0 mIU/L

Görseller

Görsel 1: ID: visual-149 | Başlık: Tiroid ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Hipoekoik, mikrokalsifikasyon içeren, düzensiz sınırlı solid nodül izlendi. | Klinik anlam: Malignite şüphesini artıran özellikler taşır. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/149_supheli_tiroid_nodulu_ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/149_supheli_tiroid_nodulu_ultrasonografi.webp | Alt text: Tiroid ultrasonografisi - Hipoekoik, mikrokalsifikasyon içeren, düzensiz sınırlı solid nodül izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu nodül için en uygun sonraki tanısal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi
B) Yıllık takip ve ileri işlem yapmama
C) Antibiyotik tedavisi başlama
D) Acil radyoaktif iyot ablasyonu
E) Laksatif tedavi

Doğru Cevap: Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi

- A) Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi: Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi şüpheli tiroid nodülünde uygun sonraki tanısal yaklaşımdır. Vakadaki “Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.” ve “Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Yıllık takip ve ileri işlem yapmama: Yıllık takip ve ileri işlem yapmama, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda “Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.” ve “Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Antibiyotik tedavisi başlama: Vakadaki Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır ve Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır. Bu olguda “Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.” ve “Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Acil radyoaktif iyot ablasyonu: Radyoaktif iyot ablasyonu sitolojik tanı olmadan ve nodül değerlendirilmeden ilk yaklaşım değildir. Bu olguda “Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.” ve “Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Laksatif tedavi: Vakadaki Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır ve Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır. Bu olguda “Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.” ve “Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Şüpheli tiroid nodülü olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.” ve “Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.” birlikte okunduğunda Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi seçeneği öne çıkar; “Radyasyon ve ailede tiroid kanseri öyküsü mevcuttur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sert düzensiz tiroid nodülü, mikrokalsifikasyon, hipoekojenite, radyasyon ve aile öyküsü malignite riskini artırır. Uygun boyut ve şüpheli ultrason özellikleri varlığında tanısal yaklaşım ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.”, “Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.” ve “Radyasyon ve ailede tiroid kanseri öyküsü mevcuttur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Nodül sert ve düzensiz sınırlıdır.

Kanıt 2: Ultrasonografide mikrokalsifikasyon ve hipoekojenite vardır.

Kanıt 3: Radyasyon ve ailede tiroid kanseri öyküsü mevcuttur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Şüpheli tiroid nodülünde temel tanısal test ince iğne aspirasyon biyopsisidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 295: v189-new-295-erken-gebelikte-asiri-bulanti-ve-kanama

Başlık: Erken gebelikte aşırı bulantı ve kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanıyı klinik, muayene ve objektif bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Mol hidatiformda yüksek beta-hCG ve kar fırtınası görünümüyle tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, erken gebelik döneminde vajinal kanama, aşırı bulantı ve kusma nedeniyle başvuruyor. Son adet tarihine göre 10 haftalık gebe olduğunu düşünmektedir. Son haftalarda gebelik haftasına göre karnının fazla büyüdüğünü ve şiddetli bulantı yaşadığını belirtmektedir.

Demografi: 24 yaşında kadın hasta | Setting: kadın doğum polikliniğinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 138/86 mmHg | Nabız: 104/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,75

Fizik Muayene

- Uterus gebelik haftasına göre büyük palpe edilir.
- Vajinal kanama koyu renklidir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum beta-hCG

Etiket: Serum beta-hCG | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Gebelik haftasına göre çok yüksek saptandı. | Klinik anlam: Trofoblastik hastalık açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Trofoblastik hastalık açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Serum beta-hCG | Sonuç özeti: Gebelik haftasına göre çok yüksek saptandı. | Yorum: Trofoblastik hastalık açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Serum beta-hCG / Gebelik haftasına göre çok yüksek saptandı. / 320000 mIU/mL / Trofoblastik hastalık açısından uyarıcıdır.

Tetkik 2: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Uterin kavitede kar fırtınası görünümü izlendi; canlı embriyo seçilemedi. | Klinik anlam: Mol hidatiform lehinedir. | Sonuç yorumu: Mol hidatiform lehinedir. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Uterin kavitede kar fırtınası görünümü izlendi; canlı embriyo seçilemedi. | Yorum: Mol hidatiform lehinedir. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / Uterin kavitede kar fırtınası görünümü izlendi; canlı embriyo seçilemedi. // Mol hidatiform lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-150 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Uterin kavitede kar fırtınası görünümü izlendi; canlı embriyo seçilemedi. | Klinik anlam: Mol hidatiform lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/150_mol_hidatiform_transvajinal_ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/150_mol_hidatiform_transvajinal_ultrasonografi.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Uterin kavitede kar fırtınası görünümü izlendi; canlı embriyo seçilemedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mol hidatiform
B) Normal intrauterin gebelik
C) Plasenta previa
D) Ektopik gebelik
E) Over torsiyonu

Doğru Cevap: Mol hidatiform

- A) Mol hidatiform: Mol hidatiform yüksek beta-hCG, büyük uterus ve kar fırtınası ultrason görünümüyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır." ve "Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Normal intrauterin gebelik: Normal intrauterin gebelikte canlı embriyo ve gebelik haftasına uygun beta-hCG beklenir; kar fırtınası görünümü olmaz. Bu olguda "Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır." ve "Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Mol hidatiform seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Plasenta previa: Plasenta previa üçüncü trimesterde ağrısız kanama ile tipiktir; erken gebelikte kar fırtınası görünümü yapmaz. Bu olguda "Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır." ve "Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Mol hidatiform seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ektopik gebelik: Vakadaki Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır ve Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir. Bu olguda "Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır." ve "Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Mol hidatiform seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Over torsiyonu: Over torsiyonu ani unilateral pelvik ağrı ve adneksiyel bulgularla seyredir; beta-hCG çok yüksekliği ve uterin görünümle açıklanmaz. Bu olguda "Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır." ve "Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir." ipuçları tanısız karar açısından Mol hidatiform seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken gebelikte aşırı bulantı ve kanama olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır." ve "Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir." birlikte okunduğunda Mol hidatiform seçeneği öne çıkar; "Ultrasonografide kar fırtınası görünümü izlenmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gebelik haftasına göre büyük uterus, aşırı bulantı-kusma, çok yüksek beta-hCG ve ultrasonografide kar fırtınası görünümü mol hidatiformu düşündürür. Trofoblastik proliferasyon beta-hCG yüksekliğinin temel nedenidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır.", "Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir." ve "Ultrasonografide kar fırtınası görünümü izlenmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Mol hidatiform en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Uterus gebelik haftasına göre büyük saptanmıştır.

Kanıt 2: Beta-hCG düzeyi gebelik haftasına göre çok yüksektir.

Kanıt 3: Ultrasonografide kar fırtınası görünümü izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Mol hidatiformda beta-hCG çok yüksektir ve ultrasonografide kar fırtınası görünümü görülebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 296: v189-new-296-erken-membran-rupturu

Başlık: Erken membran rüptürü

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Preterm erken membran rüptüründe enfeksiyon bulgusu yoksa gebelik haftasına göre yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, vajenden ani sıvı gelmesi nedeniyle başvuruyor. Sıvı gelişinin 3 saat önce başladığı, kasılma veya vajinal kanama olmadığı öğreniliyor. Ateş, kötü kokulu akıntı veya karın ağrısı tariflememektedir.

Demografi: 28 yaşında gebe hasta | Setting: gebeliğinin 31. haftasında doğum acil ünitesinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 88/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,00 (yüksek)

Fizik Muayene

- Uterus hassasiyeti yoktur.
- Spekulum muayenesinde vajende berrak sıvı birikimi izlenir.
- Fetal kalp atımı normaldir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Nitrazin testi

Etiket: Nitrazin testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Membran rüptürünü destekler. | Sonuç yorumu: Membran rüptürünü destekler. | Sonuç başlığı: Nitrazin testi | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Membran rüptürünü destekler. | Satırlar: Nitrazin testi / Pozitif saptandı. // Membran rüptürünü destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada enfeksiyon veya fetal distres bulgusu yokken en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem
- B) Hemen elektif histerektomi
- C) Ateş olmadığı için ayaktan izlem planlamak
- D) Dijital vajinal muayeneleri sık tekrarlamak
- E) Metotreksat tedavisi başlamak

Doğru Cevap: Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem

- A) Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem: Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem 31. Vakadaki "Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir." ve "Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- B) Hemen elektif histerektomi: Vakadaki Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir ve Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur. Bu olguda "Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir." ve "Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ateş olmadığı için ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir ve Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur. Bu olguda "Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir." ve "Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Dijital vajinal muayeneleri sık tekrarlamak: Vakadaki Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir ve Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur. Bu olguda "Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir." ve "Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Metotreksat tedavisi başlamak: Vakadaki Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir ve Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur. Bu olguda "Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir." ve "Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur." ipuçları tedavi önceliği açısından Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken membran rüptürü olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir." ve "Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur." birlikte okunduğunda Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem seçeneği öne çıkar; "Nitrazin testi membran rüptürünü desteklemektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: 31. haftada preterm erken membran rüptürü olan ve enfeksiyon-fetal distres bulgusu olmayan hastada bekleme yaklaşımı uygulanır. Yatış, antenatal kortikosteroid, latans antibiyotigi ve anne-fetus izlemi gerekir; dijital muayeneden kaçınılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir.", "Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur." ve "Nitrazin testi membran rüptürünü desteklemektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Yatış, antenatal kortikosteroid, antibiyotik ve yakın izlem en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Membran rüptürü 31. gebelik haftasında gelişmiştir.

Kanıt 2: Ateş, uterin hassasiyet ve fetal distres bulgusu yoktur.

Kanıt 3: Nitrazin testi membran rüptürünü desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığına seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: PPROM'da enfeksiyon yoksa gebelik haftasına göre bekleme, steroid ve antibiyotik yaklaşımı düşünülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 297: v189-new-297-ovulasyon-indüksiyonu-sonrasi-karin-sisligi

Başlık: Ovulasyon indüksiyonu sonrası karın şişliği

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanıyı klinik, muayene ve objektif bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Over hiperstimülasyon sendromunda üçüncü boşluk sıvı kaybı ve hemokonsantrasyonu tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tüp bebek tedavisi sonrası karın şişliği, nefes darlığı ve bulantı nedeniyle başvuruyor. Ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi yapıldığı, sonrasında giderek artan karın distansiyonu ve kilo artışı geliştiği öğreniliyor.

Demografi: 33 yaşında kadın hasta | Setting: kadın doğum acilinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 98/62 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,14 (yüksek)

Fizik Muayene

- Batın distandü ve hassastır.
- Hafif dispne vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hematokrit

Etiket: Hematokrit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hemokonsantrasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Hemokonsantrasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Hematokrit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hemokonsantrasyonu destekler. | Satırlar: Hematokrit / Yüksek saptandı. / 48 % / 36-46%

Tetkik 2: Pelvik ultrasonografi

Etiket: Pelvik ultrasonografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Bilateral belirgin büyümüş overler ve batında serbest sıvı izlendi. | Klinik anlam: Over hiperstimülasyon sendromu lehinedir. | Sonuç yorumu: Over hiperstimülasyon sendromu lehinedir. | Sonuç başlığı: Pelvik ultrasonografi | Sonuç özeti: Bilateral belirgin büyümüş overler ve batında serbest sıvı izlendi. | Yorum: Over hiperstimülasyon sendromu lehinedir. | Satırlar: Pelvik ultrasonografi / Bilateral belirgin büyümüş overler ve batında serbest sıvı izlendi. // Over hiperstimülasyon sendromu lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-151 | Başlık: Pelvik ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Bilateral belirgin büyümüş overler ve batında serbest sıvı izlendi. | Klinik anlam: Over hiperstimülasyon sendromu lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/151_over_hiperstimulasyon_sendromu_pelvik_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/151_over_hiperstimulasyon_sendromu_pelvik_usg.webp | Alt text: Pelvik ultrasonografi - Bilateral belirgin büyümüş overler ve batında serbest sıvı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Over hiperstimülasyon sendromu
B) Plasenta previa
C) Ablatio plasenta
D) Endometrial polip
E) Servisit

Doğru Cevap: Over hiperstimülasyon sendromu

- A) Over hiperstimülasyon sendromu: Over hiperstimülasyon sendromu yardımcı üreme tedavisi sonrası büyümüş overler, asit ve hemokonsantrasyonla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.” ve “Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleşir.
- B) Plasenta previa: Plasenta previa gebeliğin ileri döneminde ağrısız vajinal kanamaya seyreder; ovulasyon indüksiyonu sonrası asit paternini açıklamaz. Bu olguda “Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.” ve “Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Over hiperstimülasyon sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ablatio plasenta: Ablatio plasenta ağırlı vajinal kanama ve sert hassas uterusla ilişkilidir; bu hastada over büyümesi ve asit ön plandadır. Bu olguda “Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.” ve “Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Over hiperstimülasyon sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Endometrial polip: Endometrial polip anormal uterin kanama yapabilir; hemokonsantrasyon ve bilateral over büyümesi beklenmez. Bu olguda “Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.” ve “Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Over hiperstimülasyon sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Servisit: Servisit vajinal akıntı ve servikal hassasiyetle seyreder; üçüncü boşluk sıvı kaybını açıklamaz. Bu olguda “Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.” ve “Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Over hiperstimülasyon sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ovulasyon indüksiyonu sonrası karın şişliği olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.” ve “Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.” birlikte okunduğunda Over hiperstimülasyon sendromu seçeneği öne çıkar; “Hematokrit yüksekliği hemokonsantrasyonu göstermektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrası büyük overler, asit, karın distansiyonu, hemokonsantrasyon ve dispne over hiperstimülasyon sendromunu düşündürür. Artmış damar geçirgenliği üçüncü boşluğa sıvı kaçışına yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.”, “Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.” ve “Hematokrit yüksekliği hemokonsantrasyonu göstermektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Over hiperstimülasyon sendromu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakınmalar ovulasyon indüksiyonu ve hCG tetiklemesi sonrasında başlamıştır.

Kanıt 2: Ultrasonografide büyümüş overler ve batında serbest sıvı vardır.

Kanıt 3: Hematokrit yüksekliği hemokonsantrasyonu göstermektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: OHSS’de damar geçirgenliği artar; asit, hemokonsantrasyon ve tromboz riski gelişebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 298: v189-new-298-enfeksiyon-sonrasi-guacsuzluk

Başlık: Enfeksiyon sonrası güçsüzlük

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Guillain-Barré sendromunda çıkan simetrik güçsüzlük ve arefleksiyle IVIG tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacaklardan başlayıp yukarı ilerleyen güçsüzlük nedeniyle başvuruyor. İki hafta önce ishal geçirdiği, son üç gündür merdiven çıkmakta zorlandığı ve güçsüzlüğün kollara doğru ilerlediği öğreniliyor. İdrar-gaita inkontinansı yoktur.

Demografi: 34 yaşında erkek hasta | Setting: nöroloji acilinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Alt ekstremitelerde simetrik güç kaybı vardır.
- Derin tendon refleksleri alınamaz.
- Duyu kaybı hafiftir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Lomber ponksiyon

Etiket: Lomber ponksiyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Protein yüksek, hücre sayısı normal saptandı. | Klinik anlam: Albuminositolojik disosiyasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Albuminositolojik disosiyasyonu destekler. | Sonuç başlığı: Lomber ponksiyon | Sonuç özeti: Protein yüksek, hücre sayısı normal saptandı. | Yorum: Albuminositolojik disosiyasyonu destekler. | Satırlar: Lomber ponksiyon / Protein yüksek, hücre sayısı normal saptandı. // Albuminositolojik disosiyasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hastalık seyrini değiştiren uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz immünglobulin
B) Oral ağrı kesici
C) Kontrol tedavisi olarak levodopa
D) Acil antipsikotik tedavi
E) Topikal antibiyotik

Doğru Cevap: İntravenöz immünglobulin

A) İntravenöz immünglobulin: İntravenöz immünglobulin Guillain-Barré sendromunda hastalık seyrini değiştiren uygun tedavilerden biridir. Vakadaki "Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir." ve "Derin tendon refleksleri alınamamaktadır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Oral ağrı kesici: Vakadaki Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir ve Derin tendon refleksleri alınamamaktadır. Bu olguda "Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir." ve "Derin tendon refleksleri alınamamaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Kontrol tedavisi olarak levodopa: Vakadaki Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir ve Derin tendon refleksleri alınamamaktadır. Bu olguda "Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir." ve "Derin tendon refleksleri alınamamaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Acil antipsikotik tedavi: Antipsikotik tedavi psikotik ajitasyon için kullanılabilir; simetrik güçsüzlük ve arefleksi tedavi etmez. Bu olguda "Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir." ve "Derin tendon refleksleri alınamamaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Topikal antibiyotik: Topikal antibiyotik cilt enfeksiyonlarında kullanılır; periferik sinir inflamasyonunu tedavi etmez. Bu olguda "Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir." ve "Derin tendon refleksleri alınamamaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Enfeksiyon sonrası güçsüzlük olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir." ve "Derin tendon refleksleri alınamamaktadır." birlikte okunduğunda İntravenöz immünglobulin seçeneği öne çıkar; "BOS'ta protein yüksekliği ve normal hücre sayısı vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Enfeksiyon sonrası gelişen çıkan simetrik güçsüzlük, arefleksi ve albuminositolojik disosiyasyon Guillain-Barré sendromunu düşündürür. Tedavide intravenöz immünglobulin veya plazmaferez kullanılır; solunum fonksiyonu yakından izlenmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir.", "Derin tendon refleksleri alınamamaktadır." ve "BOS'ta protein yüksekliği ve normal hücre sayısı vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz immünglobulin en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Güçsüzlük enfeksiyon sonrası başlamış ve çıkan patern göstermiştir.

Kanıt 2: Derin tendon refleksleri alınamamaktadır.

Kanıt 3: BOS'ta protein yüksekliği ve normal hücre sayısı vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Guillain-Barré sendromunda IVIG veya plazmaferez kullanılır; steroid tek başına etkili değildir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 299: v189-new-299-diyabetik-hastada-siddetli-kulak-agrisi

Başlık: Diyabetik hastada şiddetli kulak ağrısı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tedavi seçimini klinik öncelik ve güvenlik üzerinden değerlendirme.

Learning Target: Malign otitis externa diyabetik hastada kafa tabanı osteomiyeliti riskini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, şiddetli sağ kulak ağrısı ve akıntı nedeniyle başvuruyor. Uzun süredir diyabeti olduğu ve kan şekeri kontrolünün kötü seyrettiği öğreniliyor. Kulak ağrısının özellikle geceleri arttığını ve basit damlalara yanıt vermediğini belirtmektedir.

Demografi: 70 yaşında erkek hasta | Setting: kulak burun boğaz acilinde değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.0°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Sağ dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve kötü kokulu akıntı vardır.
- Tragus hassasiyeti belirgindir.
- Sağ fasiyal hareketlerde hafif zayıflık izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi

Etiket: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Dış kulak yolu çevresinde kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlendi. | Klinik anlam: Malign otitis externa komplikasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Malign otitis externa komplikasyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi | Sonuç özeti: Dış kulak yolu çevresinde kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlendi. | Yorum: Malign otitis externa komplikasyonunu destekler. | Satırlar: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi / Dış kulak yolu çevresinde kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlendi. // Malign otitis externa komplikasyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-152 | Başlık: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi | Modalite: ct | Bulgu: Dış kulak yolu çevresinde kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlendi. | Klinik anlam: Malign otitis externa komplikasyonunu destekler. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/152_malign_otitis_externa_temporal_kemik_bt.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/152_malign_otitis_externa_temporal_kemik_bt.webp | Alt text: Temporal kemik bilgisayarlı tomografi - Dış kulak yolu çevresinde kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi
B) Kulak yolu temizliği sonrası ayaktan izlem
C) Topikal kinolon damla ve kültür sonucuna göre sistemik tedavi planlamak
D) Acil tonsillektomi
E) Steroidli kremle tek başına tedavi

Doğru Cevap: Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi

A) Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi: Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi malign otitis externa ve osteomiyelit riskinde uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.” ve “Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Kulak yolu temizliği sonrası ayaktan izlem: Vakadaki Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır ve Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır. Bu olguda “Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.” ve “Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Topikal kinolon damla ve kültür sonucuna göre sistemik tedavi planlamak: Vakadaki Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır ve Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır. Bu olguda “Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.” ve “Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Acil tonsillektomi: Tonsillektomi bademcik patolojileri için yapılır; dış kulak yolu ve kafa tabanı enfeksiyonunu tedavi etmez. Bu olguda “Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.” ve “Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Steroidli kremle tek başına tedavi: Vakadaki Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır ve Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır. Bu olguda “Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.” ve “Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Diyabetik hastada şiddetli kulak ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.” ve “Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.” birlikte okunduğunda Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi seçeneği öne çıkar; “BT’de kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı diyabetik hastada şiddetli gece artan otalji, dış kulak yolunda granülasyon dokusu, kraniyal sinir bulgusu ve kemik erozyonu malign otitis externayı düşündürür. En sık etken Pseudomonas aeruginosa olduğundan antipseudomonal sistemik tedavi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.”, “Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.” ve “BT’de kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Antipseudomonal sistemik antibiyotik ve yakın KBB izlemi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada kötü kontrollü diyabet öyküsü vardır.

Kanıt 2: Dış kulak yolunda granülasyon dokusu ve şiddetli otalji vardır.

Kanıt 3: BT’de kemik erozyonu ve kafa tabanı osteomiyeliti şüphesi izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Diyabetik hastada granülasyon dokulu şiddetli dış kulak yolu enfeksiyonu malign otitis externa açısından uyarıcıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 300: v189-new-300-el-uzerine-dusme-sonrasi-bilek-agrisi

Başlık: El üzerine düşme sonrası bilek ağrısı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Skafoid kırığında anatomik enfiye çukuru hassasiyetiyle immobilizasyon gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, açık el üzerine düşme sonrası el bileği ağrısı nedeniyle başvuruyor. Kaykay yaparken elini açık şekilde yere koyarak düştüğünü, sonrasında başparmak tarafında bilek ağrısı geliştiğini belirtmektedir.

Demografi: 26 yaşında erkek hasta | Setting: acil serviste ortopedi tarafından değerlendiriliyor

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Anatomik enfiye çukurunda belirgin hassasiyet vardır.
- Başparmak aksiyel yüklenmesi ağrılıdır.
- İlk grafide belirgin kırık hattı seçilememiştir.
- Distal nörovasküler muayene doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: El bileği grafisi

Etiket: El bileği grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Akut kırık hattı net izlenmedi. | Klinik anlam: Erken dönemde skafoid kırığı grafide görünmeyebilir. | Sonuç yorumu: Erken dönemde skafoid kırığı grafide görünmeyebilir. | Sonuç başlığı: El bileği grafisi | Sonuç özeti: Akut kırık hattı net izlenmedi. | Yorum: Erken dönemde skafoid kırığı grafide görünmeyebilir. | Satırlar: El bileği grafisi / Akut kırık hattı net izlenmedi. / / Erken dönemde skafoid kırığı grafide görünmeyebilir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-153 | Başlık: El bileği grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Akut kırık hattı net izlenmedi. | Klinik anlam: Erken dönemde skafoid kırığı grafide görünmeyebilir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/153_radyografide_gizli_skafoid_kirigi_bilek_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/153_radyografide_gizli_skafoid_kirigi_bilek_grafisi.webp | Alt text: El bileği grafisi - Akut kırık hattı net izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun ilk yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak
- B) Koriyucu immobilizasyon olmadan ayaktan izlem planlamak
- C) Acil karpal tünel cerrahisi yapmak
- D) Antibiyotik başlamak
- E) Bileği zorlayıcı egzersizlere hemen başlamak

Doğru Cevap: Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak

- A) Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak: Skafoid kırığı gibi kabul edip immobilizasyon planlamak anatomik enfiye çukuru hassasiyeti ve negatif ilk grafi durumunda doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.” ve “Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Koriyucu immobilizasyon olmadan ayaktan izlem planlamak: Koriyucu immobilizasyon olmadan ayaktan izlem, anatomik enfiye çukuru hassasiyeti olan düşme sonrası el bileği ağrısında okült skafoid kırık riskini yeterince karşılamaz. Bu olguda “Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.” ve “Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Acil karpal tünel cerrahisi yapmak: Karpal tünel cerrahisi median sinir basısı için yapılır; bu akut travma bulgusunun ilk tedavisi değildir. Bu olguda “Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.” ve “Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Antibiyotik başlamak: Vakadaki Travma açık el üzerine düşme şeklindedir ve Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır. Bu olguda “Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.” ve “Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Bileği zorlayıcı egzersizlere hemen başlamak: Vakadaki Travma açık el üzerine düşme şeklindedir ve Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır. Bu olguda “Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.” ve “Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: El üzerine düşme sonrası bilek ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.” ve “Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.” birlikte okunduğunda Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak seçeneği öne çıkar; “İlk grafide kırık hattı net seçilememiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Açık el üzerine düşme sonrası anatomik enfiye çukuru hassasiyeti skafoid kırığını düşündürür. İlk grafi normal olabilir; avasküler nekroz ve kaynaklama riskinden dolayı kırık dışlanana kadar immobilizasyon gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.”, “Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.” ve “İlk grafide kırık hattı net seçilememiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Skafoid kırığı gibi kabul edip başparmak destekli immobilizasyon ve kontrol görüntüleme planlamak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Travma açık el üzerine düşme şeklindedir.

Kanıt 2: Anatomik enfiye çukurunda hassasiyet vardır.

Kanıt 3: İlk grafide kırık hattı net seçilememiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Skafoid kırığı erken grafide görünmeyebilir; klinik şüphede immobilizasyon gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: internal-medicine

VAKA 301: v192-new-301-halsizlik-ve-direncli-hipotansiyon

Başlık: Halsizlik ve dirençli hipotansiyon

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: İç Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Addison krizinde hiponatremi, hiperkalemi ve hipotansiyonla acil hidrokortizon tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kusma, yaygın halsizlik ve ayakta duramama nedeniyle acile getiriliyor. Son aylarda kilo kaybı, iştahsızlık ve cilt renginde koyulaşma olduğu öğreniliyor. İki gündür gastroenterit benzeri kusma ve sıvı alamama sonrası belirgin halsizlik gelişmiştir.

Demografi: 42 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 78/46 mmHg | Nabız: 126/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,62 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta bitkin ve dehidrate görünmektedir.
- Ciltte yaygın hiperpigmentasyon vardır.
- Periferik perfüzyon zayıftır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Mineralokortikoid ve glukokortikoid eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid ve glukokortikoid eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Mineralokortikoid ve glukokortikoid eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum sodyum / 122 mmol/L / 135-145 mmol/L / Mineralokortikoid ve glukokortikoid eksikliğini destekler.

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aldosteron eksikliğiyle uyumludur. | Sonuç yorumu: Aldosteron eksikliğiyle uyumludur. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Aldosteron eksikliğiyle uyumludur. | Satırlar: Serum potasyum / 6.1 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Aldosteron eksikliğiyle uyumludur.

Tetkik 3: Serum kortizol

Etiket: Serum kortizol | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Adrenal yetmezliği destekler. | Sonuç yorumu: Adrenal yetmezliği destekler. | Sonuç başlığı: Serum kortizol | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Adrenal yetmezliği destekler. | Satırlar: Serum kortizol / 2.1 µg/dL / Sabah genellikle 5-25 µg/dL / Adrenal yetmezliği destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oral tuz desteğiyle ayaktan izlem
B) İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi
C) Spironolakton başlanması
D) Sıvı verilmeden furosemid uygulanması
E) Beta bloker başlanması

Doğru Cevap: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi

A) Oral tuz desteğiyle ayaktan izlem: Vakadaki Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır ve Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır. Bu olguda "Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi: İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi adrenal krizindeki glukokortikoid eksikliği ve dolaşım bozukluğunu hedefler. Vakadaki "Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekelenir.

C) Spironolakton başlanması: Vakadaki Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır ve Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır. Bu olguda "Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Sıvı verilmeden furosemid uygulanması: Vakadaki Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır ve Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır. Bu olguda "Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Beta bloker başlanması: Vakadaki Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır ve Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır. Bu olguda "Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Halsizlik ve dirençli hipotansiyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır." birlikte okunduğunda İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi seçeneği öne çıkar; "Cilt hiperpigmentasyonu ve düşük kortizol adrenal yetmezliği desteklemektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipotansiyon, hiponatremi, hiperkalemi, düşük kortizol ve hiperpigmentasyon primer adrenal yetmezlik zemininde Addison krizini düşündürür. Krizde tedavi geciktirilmeden intravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı resüsitasyonu başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır.", "Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır." ve "Cilt hiperpigmentasyonu ve düşük kortizol adrenal yetmezliği desteklemektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz hidrokortizon ve izotonik sıvı tedavisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada dirençli hipotansiyon ve dehidratasyon vardır.

Kanıt 2: Hiponatremi ve hiperkalemi birlikte saptanmıştır.

Kanıt 3: Cilt hiperpigmentasyonu ve düşük kortizol adrenal yetmezliği desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağına yerine geçmez.

Exam Pearl: Addison krizinde tedavi laboratuvar doğrulaması beklenmeden hidrokortizon ve izotonik sıvıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 302: v192-new-302-yasli-hastada-bilinc-bulanikligi-ve-hiperglisemi

Başlık: Yaşlı hastada bilinç bulanıklığı ve hiperglisemi

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: İç Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Hiperosmolar hiperglisemik durumda ağır hiperglisemi ve dehidratasyonla sıvı tedavisinin önceliğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bilinç bulanıklığı, ağır kuruluğu ve birkaç gündür artan idrar miktarı nedeniyle getiriliyor. Tip 2 diyabet tanısı olduğu, son hafta pnömoni nedeniyle iştahının azaldığı ve ilaçlarını düzensiz kullandığı öğreniliyor. Karın ağrısı veya derin hızlı solunum tariflenmemektedir.

Demografi: 74 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 92/58 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 20/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,28 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta dehidrate ve konfüzedir.
- Mukozalar kurudur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum glukoz

Etiket: Keton | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Çok yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır hiperglisemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Ağır hiperglisemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Serum glukoz | Sonuç özeti: Çok yüksek saptandı. | Yorum: Ağır hiperglisemiyi gösterir. | Satırlar: Serum glukoz / 780 mg/dL / 70-140 mg/dL / Ağır hiperglisemiyi gösterir.

Tetkik 2: Serum osmolalitesi

Etiket: Serum osmolalitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hiperosmolar durumu destekler. | Sonuç yorumu: Hiperosmolar durumu destekler. | Sonuç başlığı: Serum osmolalitesi | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hiperosmolar durumu destekler. | Satırlar: Serum osmolalitesi / 348 mOsm/kg / 275-295 mOsm/kg / Hiperosmolar durumu destekler.

Tetkik 3: Keton

Etiket: Keton | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin ketozis saptanmadı. | Klinik anlam: DKA yerine HHS lehinedir. | Sonuç yorumu: DKA yerine HHS lehinedir. | Sonuç başlığı: Keton | Sonuç özeti: Belirgin ketozis saptanmadı. | Yorum: DKA yerine HHS lehinedir. | Satırlar: Keton / Belirgin ketozis saptanmadı. / / DKA yerine HHS lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada ilk Tedavi basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak
- B) Subkutan kısa etkili insülin vererek ayaktan izlem planlamak
- C) Oral glukoz yüklemesi yapmak
- D) Sıvı vermeden yoğun diüretik başlamak
- E) Metformin dozunu artırmak

Doğru Cevap: İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak

- A) İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak: İzotonik sıvı resüsitasyonu HHS'de ağır dehidratasyon ve hiperosmolaliteyi düzeltmek için ilk tedavi önceliğidir. Vakadaki "Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır." ve "Belirgin ketozis saptanmamıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Subkutan kısa etkili insülin vererek ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır ve Belirgin ketozis saptanmamıştır. Bu olguda "Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır." ve "Belirgin ketozis saptanmamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Oral glukoz yüklemesi yapmak: Vakadaki Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır ve Belirgin ketozis saptanmamıştır. Bu olguda "Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır." ve "Belirgin ketozis saptanmamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Sıvı vermeden yoğun diüretik başlamak: Vakadaki Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır ve Belirgin ketozis saptanmamıştır. Bu olguda "Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır." ve "Belirgin ketozis saptanmamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Metformin dozunu artırmak: Metformin dozunu artırmak akut HHS tedavisi değildir ve dehidrate hastada laktik asidoz riskini artırabilir. Bu olguda "Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır." ve "Belirgin ketozis saptanmamıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yaşlı hastada bilinç bulanıklığı ve hiperglisemi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır." ve "Belirgin ketozis saptanmamıştır." birlikte okunduğunda İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak seçeneği öne çıkar; "Hastada dehidratasyon, hipotansiyon ve bilinç bulanıklığı vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı tip 2 diyabetli hastada ağır hiperglisemi, yüksek osmolalite, belirgin ketozis olmaması, dehidratasyon ve bilinç değişikliği hiperosmolar hiperglisemik durumu düşündürür. Tedavide ilk öncelik intravasküler hacmi düzeltmek için izotonik sıvı resüsitasyonudur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır.", "Belirgin ketozis saptanmamıştır." ve "Hastada dehidratasyon, hipotansiyon ve bilinç bulanıklığı vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İzotonik sıvı resüsitasyonu başlamak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Serum glukozu çok yüksek ve serum osmolalitesi artmıştır.

Kanıt 2: Belirgin ketozis saptanmamıştır.

Kanıt 3: Hastada dehidratasyon, hipotansiyon ve bilinç bulanıklığı vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: HHS'de en kritik başlangıç tedavisi agresif sıvı replasmanıdır; insülin daha dikkatli ve sonraki basamakta verilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 303: v192-new-303-kabizlik-poliuri-ve-konfuzyon

Başlık: Kabızlık, poliüri ve konfüzyon

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: İç Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Hiperkalsemide malignite şüphesiyle ilk sıvı ve antiresorptif yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, halsizlik, kabızlık, sık idrara çıkma ve bilinç bulanıklığı nedeniyle getiriliyor. Son iki ayda belirgin kilo kaybı ve iştahsızlık olduğu öğreniliyor. Uzun süreli sigara öyküsü vardır. Yakınları son günlerde su içmesinin arttığını ve dalginlaştığını belirtmektedir.

Demografi: 66 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/62 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,12 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta dehidrate ve konfüzidir.
- Akciğer sağ üst alanda solunum sesleri azalmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kalsiyum

Etiket: Serum kalsiyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Semptomatik ağır hiperkalsemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Semptomatik ağır hiperkalsemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Serum kalsiyum | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Semptomatik ağır hiperkalsemiyi gösterir. | Satırlar: Serum kalsiyum / 14.2 mg/dL / 8.5-10.5 mg/dL / Semptomatik ağır hiperkalsemiyi gösterir.

Tetkik 2: PTH

Etiket: PTH | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Baskılanmış saptandı. | Klinik anlam: PTH dışı hiperkalsemi nedenini destekler. | Sonuç yorumu: PTH dışı hiperkalsemi nedenini destekler. | Sonuç başlığı: PTH | Sonuç özeti: Baskılanmış saptandı. | Yorum: PTH dışı hiperkalsemi nedenini destekler. | Satırlar: PTH / Baskılanmış saptandı. / / PTH dışı hiperkalsemi nedenini destekler.

Tetkik 3: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ üst lobda kitle ile uyumlu opasite izlendi. | Klinik anlam: Malignite ilişkili hiperkalsemi olasılığını artırır. | Sonuç yorumu: Malignite ilişkili hiperkalsemi olasılığını artırır. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Sağ üst lobda kitle ile uyumlu opasite izlendi. | Yorum: Malignite ilişkili hiperkalsemi olasılığını artırır. | Satırlar: Akciğer grafisi / Sağ üst lobda kitle ile uyumlu opasite izlendi. / / Malignite ilişkili hiperkalsemi olasılığını artırır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-154 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ üst lobda kitle ile uyumlu opasite izlendi. | Klinik anlam: Malignite ilişkili hiperkalsemi olasılığını artırır. | URL: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/154_sag_ust_lob_kitle_akciger_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxcitqdsd.public.blob.vercel-storage.com/154_sag_ust_lob_kitle_akciger_grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Sağ üst lobda kitle ile uyumlu opasite izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kalsiyum replasmanı ve D vitamini yüklemesi
- B) Oral hidrasyon ve yakın ayaktan izlem planlamak
- C) İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi
- D) Tiazid diüretik başlamak
- E) Metformin başlamak

Doğru Cevap: İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi

- A) Kalsiyum replasmanı ve D vitamini yüklemesi: Vakadaki Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir ve PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur. Bu olguda “Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.” ve “PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Oral hidrasyon ve yakın ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir ve PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur. Bu olguda “Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.” ve “PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi: İzotonik sıvı resüsitasyonu ve intravenöz bisfosfonat tedavisi semptomatik malignite ilişkili hiperkalsemide uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.” ve “PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- D) Tiazid diüretik başlamak: Vakadaki Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir ve PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur. Bu olguda “Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.” ve “PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Metformin başlamak: Vakadaki Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir ve PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur. Bu olguda “Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.” ve “PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.” ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kabızlık, poliüri ve konfüzyon olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.” ve “PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.” birlikte okunduğunda İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi seçeneği öne çıkar; “Hastada dehidratasyon ve bilinç bulanıklığı vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Semptomatik ağır hiperkalsemide poliüri ve dehidratasyon kalsiyumu daha da artırabilir. İlk tedavi izotonik sıvı ile hacim replasmanıdır; malignite ilişkili hiperkalsemide kalıcı kontrol için intravenöz bisfosfonat eklenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.”, “PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.” ve “Hastada dehidratasyon ve bilinç bulanıklığı vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İzotonik sıvı resüsitasyonu ve ardından intravenöz bisfosfonat tedavisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Serum kalsiyumu belirgin yüksek ve hasta semptomatiktir.

Kanıt 2: PTH baskılanmış ve akciğer kitlesi mevcuttur.

Kanıt 3: Hastada dehidratasyon ve bilinç bulanıklığı vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ağır hiperkalsemide ilk basamak izotonik sıvıdır; malignite ilişkili olguda bisfosfonat eklenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 304: v192-new-304-halsizlik-ve-pika

Başlık: Halsizlik ve pika

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: İç Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Demir eksikliği anemisinde mikrositik hipokrom anemi ve düşük ferritin bulgularıyla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, halsizlik, çabuk yorulma ve buz yeme isteği nedeniyle başvuruyor. Son bir yıldır adet kanamalarının yoğun olduğu, son aylarda eforla çarpıntı ve saç dökülmesi geliştiği öğreniliyor. Kronik böbrek hastalığı yoktur.

Demografi: 38 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 108/68 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,89

Fizik Muayene

- Hasta soluk görünmektedir.
- Tırnaklarda hafif kaşıkleşme vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Anemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Anemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Anemiyi gösterir. | Satırlar: Hemoglobin / 8.9 g/dL / 12-16 g/dL / Anemiyi gösterir.

Tetkik 2: MCV

Etiket: MCV | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Mikrositik anemi paternini destekler. | Sonuç yorumu: Mikrositik anemi paternini destekler. | Sonuç başlığı: MCV | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Mikrositik anemi paternini destekler. | Satırlar: MCV / 68 fL / 80-100 fL / Mikrositik anemi paternini destekler.

Tetkik 3: Ferritin

Etiket: Ferritin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Demir depolarının azaldığını gösterir. | Sonuç yorumu: Demir depolarının azaldığını gösterir. | Sonuç başlığı: Ferritin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Demir depolarının azaldığını gösterir. | Satırlar: Ferritin / 6 ng/mL / 15-150 ng/mL / Demir depolarının azaldığını gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vitamin B12 eksikliği anemisi
B) Demir eksikliği anemisi
C) Aplastik anemi
D) Akut hemolitik anemi
E) Polisitemia vera

Doğru Cevap: Demir eksikliği anemisi

- A) Vitamin B12 eksikliği anemisi: Vitamin B12 eksikliği genellikle makrositik anemi ve nörolojik bulgularla seyreder; bu hastada MCV düşüktür. Bu olguda “Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.” ve “MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Demir eksikliği anemisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği anemisi yoğun adet kanaması, pika, düşük MCV ve düşük ferritinle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.” ve “MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- C) Aplastik anemi: Aplastik anemide pansitopeni beklenir; burada demir depoları azalmasına bağlı mikrositoz ön plandadır. Bu olguda “Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.” ve “MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Demir eksikliği anemisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Akut hemolitik anemi: Akut hemolitik anemide sarılık, LDH artışı ve retikülositöz beklenir; düşük ferritin temel bulgu değildir. Bu olguda “Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.” ve “MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Demir eksikliği anemisi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Polisitemia vera: Vakadaki Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır ve MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır. Bu olguda “Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.” ve “MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Demir eksikliği anemisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Halsizlik ve pika olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.” ve “MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.” birlikte okunduğunda Demir eksikliği anemisi seçeneği öne çıkar; “Ferritin düzeyi belirgin düşüktür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yoğun adet kanaması, pika, koilonişi, mikrositik anemi ve düşük ferritin demir eksikliği anemisini düşündürür. Ferritin demir depolarını yansıtır ve düşük olması tanıda güçlü destek sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.”, “MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.” ve “Ferritin düzeyi belirgin düşüktür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Demir eksikliği anemisi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada yoğun adet kanaması öyküsü vardır.

Kanıt 2: MCV düşük ve hemoglobin azalmıştır.

Kanıt 3: Ferritin düzeyi belirgin düşüktür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Demir eksikliği anemisinde ferritin düşüktür; kronik hastalık anemisinde ferritin normal veya yüksek olabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 305: v192-new-305-hemoptizi-ve-bobrek-yetmezligi

Başlık: Hemoptizi ve böbrek yetmezliği

Branş: internal-medicine | İlgili Branş: İç Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Anti-GBM hastalığında pulmoner hemoraji ve hızlı ilerleyen glomerülonefriti tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, kanlı balgam, nefes darlığı ve idrar renginde koyulaşma nedeniyle başvuruyor. Son bir haftada halsizlik ve az idrar yapma geliştiği, son iki gündür hemoptizi olduğu öğreniliyor. Bilinen sistemik hastalığı yoktur.

Demografi: 29 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 152/94 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %90% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,80

Fizik Muayene

- Hasta soluk ve dispneiktir.
- Akciğerlerde bilateral raller duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut böbrek hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Akut böbrek hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut böbrek hasarını destekler. | Satırlar: Serum kreatinin / 3.2 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Akut böbrek hasarını destekler.

Tetkik 2: İdrar mikroskopisi

Etiket: İdrar mikroskopisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Eritrosit silendirleri izlendi. | Klinik anlam: Glomerüler hematüriyi destekler. | Sonuç yorumu: Glomerüler hematüriyi destekler. | Sonuç başlığı: İdrar mikroskopisi | Sonuç özeti: Eritrosit silendirleri izlendi. | Yorum: Glomerüler hematüriyi destekler. | Satırlar: İdrar mikroskopisi / Eritrosit silendirleri izlendi. // Glomerüler hematüriyi destekler.

Tetkik 3: Anti-GBM antikor

Etiket: Anti-GBM antikor | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Anti-glomerüler bazal membran hastalığını destekler. | Sonuç yorumu: Anti-glomerüler bazal membran hastalığını destekler. | Sonuç başlığı: Anti-GBM antikor | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Anti-glomerüler bazal membran hastalığını destekler. | Satırlar: Anti-GBM antikor / Pozitif saptandı. // Anti-glomerüler bazal membran hastalığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-155 | Başlık: İdrar mikroskopisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Eritrosit silendirleri izlendi. | Klinik anlam: Glomerüler hematüriyi destekler. | URL: https://iukbtlkzictqsds.public.blob.vercel-storage.com/155_eritrosit_silendirir_idrar_mikroskopisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzictqsds.public.blob.vercel-storage.com/155_eritrosit_silendirir_idrar_mikroskopisi.webp | Alt text: İdrar mikroskopisi - Eritrosit silendirleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Minimal değişiklik hastalığı
B) Anti-GBM hastalığı
C) Poststreptokoksik glomerülonefrit
D) IgA nefropatisi
E) Diyabetik nefropati

Doğru Cevap: Anti-GBM hastalığı

A) Minimal değişiklik hastalığı: Minimal değişiklik hastalığı nefrotik sendrom yapar; hemoptizi ve eritrosit silendirleri beklenmez. Bu olguda “Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.” ve “Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Anti-GBM hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
B) Anti-GBM hastalığı: Anti-GBM hastalığı pulmoner hemoraji, glomerülonefrit ve anti-GBM pozitifliğiyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.” ve “Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
C) Poststreptokoksik glomerülonefrit: Poststreptokoksik glomerülonefrit enfeksiyon sonrası nefrit ve düşük komplemanla seyreder; anti-GBM pozitifliği beklenmez. Bu olguda “Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.” ve “Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Anti-GBM hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
D) IgA nefropatisi: IgA nefropatisi üst solunum yolu enfeksiyonuyla eş zamanlı hematüri yapabilir; pulmoner hemoraji tipik değildir. Bu olguda “Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.” ve “Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Anti-GBM hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Diyabetik nefropati: Diyabetik nefropati kronik albuminüri ve glomerülosklerozla seyreder; akut hemoptizi-glomerülonefrit paternini açıklamaz. Bu olguda “Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.” ve “Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Anti-GBM hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Hemoptizi ve böbrek yetmezliği olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.” ve “Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.” birlikte okunduğunda Anti-GBM hastalığı seçeneği öne çıkar; “Anti-GBM antikor pozitif saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hemoptizi, akciğer infiltrasyon bulguları, akut böbrek hasarı, eritrosit silendirleri ve anti-GBM antikor pozitifliği anti-GBM hastalığını düşündürür. Glomerüler ve alveoler bazal membran hedeflenir; hızlı tedavi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.”, “Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.” ve “Anti-GBM antikor pozitif saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Anti-GBM hastalığı en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada hemoptizi ve nefes darlığı vardır.

Kanıt 2: Kreatinin yüksekliği ve eritrosit silendirleri glomerülonefriti destekler.

Kanıt 3: Anti-GBM antikor pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Anti-GBM hastalığında pulmoner hemoraji ve hızlı ilerleyen glomerülonefrit birlikte görülebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 306: v194-new-306-dogum-analjezisi-sonrasi-perineal-uyusma

Başlık: Doğum analjezisi sonrası perineal uyuşma

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Pudendal sinirin ischial spine komşuluğunu ve perineal duyu-motor etkilenimini klinik uygulamayla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, doğum eylemi sırasında perineal ağrının azalması ve geçici perineal uyuşma gelişmesi nedeniyle izleniyor. Vajinal doğumun ikinci evresinde analjezi amacıyla transvajinal pudendal blok uygulandığı öğreniliyor. Uygulama sonrası kasık veya uylukta belirgin motor kayıp olmamıştır.

Demografi: 27 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması vardır.
- Anal sfinkter kasılma gücü hafif azalmıştır.
- Uyluk adduksiyonu ve diz ekstansiyonu korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu blok sırasında hedeflenen sinirin en önemli anatomik işaret noktası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spina iliaca anterior superior
- B) Spina ischiadica
- C) Trochanter major
- D) Tuberculum pubicum
- E) Caput fibulae

Doğru Cevap: Spina ischiadica

A) Spina iliaca anterior superior: Spina iliaca anterior superior inguinal bölge ve lateral femoral kutanöz sinir için daha anlamlıdır; pudendal blok hedef noktası değildir. Bu olguda “Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.” ve “Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Spina ischiadica seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Spina ischiadica: Spina ischiadica nervus pudendusun geçtiği ligamentum sacrospinale komşuluğunda olduğu için pudendal blokta temel işaret noktasıdır. Vakadaki “Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.” ve “Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

C) Trochanter major: Trochanter major kalça lateral kemik çıkıntısıdır; pudendal sinirin perineal seyri için hedef nokta değildir. Bu olguda “Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.” ve “Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Spina ischiadica seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Tuberculum pubicum: Tuberculum pubicum inguinal kanal ve ligamentum inguinale ilişkilerinde önemlidir; pudendal blokta ana kılavuz değildir. Bu olguda “Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.” ve “Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Spina ischiadica seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Caput fibulae: Caput fibulae nervus fibularis communis için önemlidir; perineal analjeziyle ilişkili değildir. Bu olguda “Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.” ve “Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Spina ischiadica seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Doğum analjezisi sonrası perineal uyuşma olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.” ve “Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Spina ischiadica seçeneği öne çıkar; “Uyluk motor fonksiyonları korunmuştur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nervus pudendus pelvis dışına foramen infrapiriforme aracılığıyla çıkar, spina ischiadica ve ligamentum sacrospinale komşuluğundan geçerek perineye ulaşır. Pudendal blokta spina ischiadica önemli bir palpasyon ve enjeksiyon kılavuzudur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.”, “Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.” ve “Uyluk motor fonksiyonları korunmuştur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Spina ischiadica en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Blok doğum eyleminde perineal analjezi için uygulanmıştır.

Kanıt 2: Perine ve dış genital bölgede geçici duyu azalması gelişmiştir.

Kanıt 3: Uyluk motor fonksiyonları korunmuştur.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olgusuyla uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Pudendal blokta temel anatomik kılavuz spina ischiadica ve ligamentum sacrospinale komşuluğudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 307: v194-new-307-testis-kitlesinde-lenf-nodu-degerlendirmesi

Başlık: Testis kitlesinde lenf nodu değerlendirilmesi

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Anatomi yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Testisin lenf drenajını embriyolojik iniş kökeniyle paraaortik lenf nodlarına bağlayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ testiste ağrısız sert kitle fark etmesi nedeniyle başvuruyor. Kitlenin birkaç haftadır büyüdüğünü, travma veya enfeksiyon bulgusu olmadığını belirtmektedir. Skrotal ciltte belirgin lezyon yoktur.

Demografi: 31 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ testiste sert, düzensiz sınırlı kitle palpe edilir.
- Skrotal cilt normaldir.
- Inguinal bölgede belirgin lenf nodu palpe edilmez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Skrotal ultrasonografi

Etiket: Skrotal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ testis içinde solid hipoekoik kitle izlendi. | Klinik anlam: Testis tümörü açısından şüpheli bulgudur. | Sonuç yorumu: Testis tümörü açısından şüpheli bulgudur. | Sonuç başlığı: Skrotal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sağ testis içinde solid hipoekoik kitle izlendi. | Yorum: Testis tümörü açısından şüpheli bulgudur. | Satırlar: Skrotal ultrasonografi / Sağ testis içinde solid hipoekoik kitle izlendi. / / Testis tümörü açısından şüpheli bulgudur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-156 | Başlık: Skrotal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sağ testis içinde solid hipoekoik kitle izlendi. | Klinik anlam: Testis tümörü açısından şüpheli bulgudur. | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/156_testis_solid_hipoekoik_kitle_skrotal_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/156_testis_solid_hipoekoik_kitle_skrotal_usg.webp | Alt text: Skrotal ultrasonografi - Sağ testis içinde solid hipoekoik kitle izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Testis tümöründe ilk lenfatik yayılımın en olası olduğu lenf nodu grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yüzeyel inguinal lenf nodları
B) Paraaortik lenf nodları
C) Popliteal lenf nodları
D) Aksiller lenf nodları
E) Submandibular lenf nodları

Doğru Cevap: Paraaortik lenf nodları

- A) Yüzeyel inguinal lenf nodları: Yüzeyel inguinal lenf nodları skrotal deri drenajında önemlidir; testis parankiminin primer lenfatik drenajı değildir. Bu olguda “Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.” ve “Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Paraaortik lenf nodları seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Paraaortik lenf nodları: Paraaortik lenf nodları testisin embriyolojik abdominal kökeni nedeniyle beklenen ilk lenfatik yayılım bölgesidir. Vakadaki “Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.” ve “Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- C) Popliteal lenf nodları: Popliteal lenf nodları bacak arka-lateral yüzey drenajıyla ilişkilidir; testis drenajını açıklamaz. Bu olguda “Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.” ve “Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Paraaortik lenf nodları seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Aksiller lenf nodları: Aksiller lenf nodları üst ekstremit ve meme drenajıyla ilişkilidir; testis tümörü için uygun değildir. Bu olguda “Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.” ve “Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Paraaortik lenf nodları seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Submandibular lenf nodları: Submandibular lenf nodları yüz ve ağız boşluğu drenajında önemlidir; testis lenf drenajıyla ilişkili değildir. Bu olguda “Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.” ve “Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Paraaortik lenf nodları seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Testis kitlesinde lenf nodu değerlendirilmesi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.” ve “Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.” birlikte okunduğunda Paraaortik lenf nodları seçeneği öne çıkar; “Soru testis tümörünün lenfatik yayılımını sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Testis embriyolojik olarak posterior abdominal duvardan gelişip skrotuma iner. Bu nedenle testisin lenf drenajı skrotal deriden farklı olarak paraaortik lenf nodlarına olur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.”, “Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.” ve “Soru testis tümörünün lenfatik yayılımını sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Paraaortik lenf nodları en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kitle testis parankimi içinde yerleşmiştir.

Kanıt 2: Skrotal ciltte primer lezyon tarifi lenmemiştir.

Kanıt 3: Soru testis tümörünün lenfatik yayılımını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Testis paraaortik lenf nodlarına, skrotal deri ise yüzeyel inguinal lenf nodlarına drene olur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 308: v194-new-308-boyun-cerrahisi-sonrasi-sut-gorunumunde-drenaj

Başlık: Boyun cerrahisi sonrası süt görünümünde drenaj

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomi yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Torasik kanal yaralanmasını sol venöz açı ve şilotoraks gelişimiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sol supraklaviküler diseksiyon sonrası dreninden süt renginde sıvı gelmesi nedeniyle izleniyor. Metastatik lenf nodu nedeniyle sol alt boyun diseksiyonu yapıldığı öğreniliyor. Ameliyat sonrası özellikle enteral beslenme başlandıktan sonra drenaj miktarı artmıştır.

Demografi: 55 yaşında kadın hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/72 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,78

Fizik Muayene

- Sol boyun dreninde süt görünümünde sıvı vardır.
- Solunum sıkıntısı hafiftir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Dren sıvısı trigliserid düzeyi

Etiket: Dren sıvısı trigliserid düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Lenfatik şilöz kaçağı destekler. | Sonuç yorumu: Lenfatik şilöz kaçağı destekler. | Sonuç başlığı: Dren sıvısı trigliserid düzeyi | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Lenfatik şilöz kaçağı destekler. | Satırlar: Dren sıvısı trigliserid düzeyi / 420 mg/dL / / Lenfatik şilöz kaçağı destekler.

Tetkik 2: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol plevral alanda sıvı artışı izlendi. | Klinik anlam: Şilotoraks gelişimini düşündürür. | Sonuç yorumu: Şilotoraks gelişimini düşündürür. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Sol plevral alanda sıvı artışı izlendi. | Yorum: Şilotoraks gelişimini düşündürür. | Satırlar: Akciğer grafisi / Sol plevral alanda sıvı artışı izlendi. / / Şilotoraks gelişimini düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-157 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sol plevral alanda sıvı artışı izlendi. | Klinik anlam: Şilotoraks gelişimini düşündürür. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/157_silotoraks_sol_plevral_efusyon_grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/157_silotoraks_sol_plevral_efusyon_grafi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Sol plevral alanda sıvı artışı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tabloda yaralanması en olası yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ductus thoracicus
B) Ductus cysticus
C) Ductus pancreaticus
D) Ureter dexter
E) Ductus deferens

Doğru Cevap: Ductus thoracicus

- A) Ductus thoracicus: Ductus thoracicus sol venöz açıya döküldüğü için sol alt boyun cerrahisi sonrası şilöz drenajın en olası kaynağıdır. Vakadaki “Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.” ve “Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Ductus cysticus: Ductus cysticus safra kesesi ile safra yolları arasındadır; boyunda süt renkli lenf kaçağı oluşturmaz. Bu olguda “Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.” ve “Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Ductus thoracicus seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ductus pancreaticus: Ductus pancreaticus pankreas salgısını duodenuma taşır; sol supraklaviküler drenajla ilişkili değildir. Bu olguda “Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.” ve “Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Ductus thoracicus seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ureter dexter: Ureter dexter sağ böbrekten mesaneye idrar taşır; boyun cerrahisi sonrası şilotoraksı açıklamaz. Bu olguda “Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.” ve “Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Ductus thoracicus seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Ductus deferens: Ductus deferens spermi taşır ve skrotal-pelvik yapıdadır; sol boyun şilöz kaçağıyla ilişkili değildir. Bu olguda “Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.” ve “Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.” ipuçları tanısız karar açısından Ductus thoracicus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Boyun cerrahisi sonrası süt görünümünde drenaj olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.” ve “Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.” birlikte okunduğunda Ductus thoracicus seçeneği öne çıkar; “Enteral beslenme sonrası drenaj miktarı artmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ductus thoracicus vücudun büyük kısmının lenfini taşır ve sol venöz açıya dökülür. Sol alt boyun cerrahilerinde yaralanırsa şilöz drenaj ve şilotoraks gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.”, “Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.” ve “Enteral beslenme sonrası drenaj miktarı artmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ductus thoracicus en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Cerrahi sol supraklaviküler bölgede yapılmıştır.

Kanıt 2: Dren sıvısı süt görünümündedir ve trigliserid düzeyi yüksektir.

Kanıt 3: Enteral beslenme sonrası drenaj miktarı artmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Torasik kanal sol venöz açıya dökülür ve yaralanması şilöz kaçak oluşturur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 309: v194-new-309-karbondioksit-tasinmasi-mekanizmasi

Başlık: Karbondioksit taşınması mekanizması

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Haldane etkisini akciğerde oksijenlenmenin karbondioksit taşınmasına etkisiyle açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde akciğer kapillerinde hemoglobinin oksijenlenmesiyle karbondioksit taşınmasının nasıl değiştiği tartışılıyor. Bilinen solunum hastalığı yoktur. Değerlendirme gaz taşınması mekanizmalarını anlamak amacıyla yapılmaktadır.

Demografi: 24 yaşında sağlıklı gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 14/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Fizik muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fizyolojik simülasyon

Etiket: Fizyolojik simülasyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pulmoner kapillerde hemoglobin oksijen saturasyonu artmış olarak modellendi. | Klinik anlam: Haldane etkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç yorumu: Haldane etkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç başlığı: Fizyolojik simülasyon | Sonuç özeti: Pulmoner kapillerde hemoglobin oksijen saturasyonu artmış olarak modellendi. | Yorum: Haldane etkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. | Satırlar: Fizyolojik simülasyon / Pulmoner kapillerde hemoglobin oksijen saturasyonu artmış olarak modellendi. / / Haldane etkisini değerlendirmek için kullanılmıştır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Akciğerde hemoglobinin oksijenlenmesi karbondioksit atılımını hangi mekanizmayla kolaylaştırır?

- A) Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak
B) Alveoler ventilasyonu tamamen durdurarak
C) Karbondioksiti irreversibl olarak hemoglobine bağlayarak
D) Bikarbonat oluşumunu kalıcı olarak engelleyerek
E) Eritrosit membranını karbondioksit geçirimsiz hale getirerek

Doğru Cevap: Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak

A) Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak: Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesinin azalması Haldane etkisinin temel mekanizmasıdır. Vakadaki "Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir." ve "Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçeneğin klinik olarak gerçekleştiği görülmektedir.

B) Alveoler ventilasyonu tamamen durdurarak: Vakadaki Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir ve Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır. Bu olguda "Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir." ve "Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Karbondioksiti irreversibl olarak hemoglobine bağlayarak: Karbondioksitin irreversibl bağlanması gaz değişimini engeller; Haldane etkisi geri dönüşümlü taşıma üzerine kuruludur. Bu olguda "Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir." ve "Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Bikarbonat oluşumunu kalıcı olarak engelleyerek: Bikarbonat oluşumunun kalıcı engellenmesi karbondioksit taşınmasını bozar; akciğerdeki salınım mekanizması bu değildir. Bu olguda "Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir." ve "Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Eritrosit membranını karbondioksit geçirimsiz hale getirerek: Eritrosit membranının karbondioksit geçirimsiz olması karbondioksit taşınmasını engeller; fizyolojik duruma uyumlu değildir. Bu olguda "Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir." ve "Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Karbondioksit taşınması mekanizması olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir." ve "Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır." birlikte okunduğunda Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak seçeneği öne çıkar; "Soru karbondioksit atılımının kolaylaşmasını sorgulamaktadır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Haldane etkisine göre oksijenlenmiş hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonu taşıma kapasitesi azalır. Bu durum pulmoner kapillerde karbondioksitin hemoglobinden ayrılmasını ve alveole atılmasını kolaylaştırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir.", "Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır." ve "Soru karbondioksit atılımının kolaylaşmasını sorgulamaktadır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hemoglobinin karbondioksit ve hidrojen iyonlarına afinitesini azaltarak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Simülasyon pulmoner kapillerde gerçekleşmektedir.

Kanıt 2: Hemoglobin oksijen saturasyonu artmıştır.

Kanıt 3: Soru karbondioksit atılımının kolaylaşmasını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Haldane etkisi akciğerde oksijenlenmenin karbondioksit salınımını kolaylaştırmasıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 310: v194-new-310-bobrek-plazma-akimi-olcumu

Başlık: Böbrek plazma akımı ölçümü

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Laboratuvar bulgusunu klinik bağlamla yorumlama.

Learning Target: Renal plazma akımının PAH klirensiyle neden tahmin edildiğini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde renal plazma akımının hangi madde klirensiyle tahmin edilebileceği tartışılıyor. Bilinen böbrek hastalığı yoktur. Çalışma, renal klirens kavramlarını değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Demografi: 30 yaşında sağlıklı gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 70/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,63

Fizik Muayene

- Fizik muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Klirens simülasyonu

Etiket: Klirens simülasyonu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük plazma düzeyinde filtre edilen ve proksimal tübülenden yoğun sekrete edilen bir madde modellendi. | Klinik anlam: Etketif renal plazma akımı ölçümünü temsil eder. | Sonuç yorumu: Etketif renal plazma akımı ölçümünü temsil eder. | Sonuç başlığı: Klirens simülasyonu | Sonuç özeti: Düşük plazma düzeyinde filtre edilen ve proksimal tübülenden yoğun sekrete edilen bir madde modellendi. | Yorum: Etketif renal plazma akımı ölçümünü temsil eder. | Satırlar: Klirens simülasyonu | Düşük plazma düzeyinde filtre edilen ve proksimal tübülenden yoğun sekrete edilen bir madde modellendi. // Etketif renal plazma akımı ölçümünü temsil eder.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu özelliklere sahip ve efektif renal plazma akımını tahmin etmek için kullanılan madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnülin
- B) Para-aminohippurat
- C) Glukoz
- D) Üre
- E) Albumin

Doğru Cevap: Para-aminohippurat

A) İnülin: İnülin filtre edilir ancak sekrete veya reabsorbe edilmez; glomerüler filtrasyon hızını ölçmek için kullanılır. Bu olguda “Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.” ve “Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.” ipuçları klinik karar açısından Para-aminohippurat seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Para-aminohippurat: Para-aminohippurat proksimal tübüler sekresyonla büyük ölçüde temizlendiği için efektif renal plazma akımını tahmin eder. Vakadaki “Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.” ve “Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Glukoz: Vakadaki Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir ve Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir. Bu olguda “Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.” ve “Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.” ipuçları klinik karar açısından Para-aminohippurat seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Üre: Üre hem geri emilim hem sekresyon süreçlerinden etkilenebilir; PAH kadar renal plazma akımını temsil etmez. Bu olguda “Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.” ve “Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.” ipuçları klinik karar açısından Para-aminohippurat seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Albumin: Vakadaki Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir ve Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir. Bu olguda “Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.” ve “Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.” ipuçları klinik karar açısından Para-aminohippurat seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Böbrek plazma akımı ölçümü olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.” ve “Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.” birlikte okunduğunda Para-aminohippurat seçeneği öne çıkar; “Değerlendirme düşük plazma düzeyindeki klirens üzerinden yapılmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Para-aminohippurat düşük konsantrasyonlarda hem glomerülden filtre edilir hem de proksimal tübülenden etkin şekilde sekrete edilir. Böbrekten tek geçişte büyük ölçüde temizlendiği için efektif renal plazma akımını tahmin etmede kullanılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.”, “Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.” ve “Değerlendirme düşük plazma düzeyindeki klirens üzerinden yapılmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Para-aminohippurat en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Simülasyonda madde hem filtre edilmekte hem de yoğun sekrete edilmektedir.

Kanıt 2: Amaç renal plazma akımını tahmin etmektir.

Kanıt 3: Değerlendirme düşük plazma düzeyindeki klirens üzerinden yapılmaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: İnülin GFR’yi, PAH efektif renal plazma akımını tahmin eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 311: v194-new-311-mide-asit-salgisinin-son-basamagi

Başlık: Mide asit salgısının son basamağı

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Gastrik parietal hücre asit sekresyonunda H/K ATPaz pompasını mekanizma olarak tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hastada mide asit salgısını azaltan ilaçların hedeflediği son ortak basamak tartışılıyor. Uzun süredir reflü yakınmaları olduğu ve proton pompa inhibitörü kullandığında şikâyetlerinin azaldığı öğreniliyor. Soru, ilaçtan çok fizyolojik asit salgı mekanizmasına yöneliktir.

Demografi: 40 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fizik muayenesi doğaldır.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fizyoloji değerlendirmesi

Etiket: Fizyoloji değerlendirmesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Parietal hücre apikal membranındaki proton pompası hedef mekanizma olarak incelendi. | Klinik anlam: Asit sekresyonunun son ortak basamağını temsil eder. | Sonuç yorumu: Asit sekresyonunun son ortak basamağını temsil eder. | Sonuç başlığı: Fizyoloji değerlendirmesi | Sonuç özeti: Parietal hücre apikal membranındaki proton pompası hedef mekanizma olarak incelendi. | Yorum: Asit sekresyonunun son ortak basamağını temsil eder. | Satırlar: Fizyoloji değerlendirmesi | Parietal hücre apikal membranındaki proton pompası hedef mekanizma olarak incelendi. // Asit sekresyonunun son ortak basamağını temsil eder.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Parietal hücreden mide lümenine hidrojen iyonu salgılanmasını sağlayan temel taşıyıcı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Na/K ATPaz
B) H/K ATPaz
C) Na/glukoz kotransporter
D) Aquaporin-2
E) Na/K/2Cl kotransporter

Doğru Cevap: H/K ATPaz

- A) Na/K ATPaz: Na/K ATPaz bazolateral iyon gradyanlarını sürdürür ancak mide lümenine proton salgısının son basamağı değildir. Bu olguda “Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.” ve “Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından H/K ATPaz seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) H/K ATPaz: H/K ATPaz parietal hücre apikal membranında hidrojen iyonunu lümene salgılayan temel proton pompasıdır. Vakadaki “Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.” ve “Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- C) Na/glukoz kotransporter: Na/glukoz kotransporter bağırsak ve proksimal tübülde glukoz taşınmasıyla ilişkilidir; mide asit salgısını sağlamaz. Bu olguda “Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.” ve “Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından H/K ATPaz seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Aquaporin-2: Aquaporin-2 toplayıcı kanalda su geçirgenliğini düzenler; parietal hücre asit salgısıyla ilişkili değildir. Bu olguda “Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.” ve “Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından H/K ATPaz seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Na/K/2Cl kotransporter: Na/K/2Cl kotransporter böbrek Henle kulpu ve bazı epitellerde iyon taşır; mide lümenine proton salgılamaz. Bu olguda “Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.” ve “Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.” ipuçları klinik karar açısından H/K ATPaz seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Mide asit salgısının son basamağı olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.” ve “Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.” birlikte okunduğunda H/K ATPaz seçeneği öne çıkar; “Soru parietal hücre asit salgısının son basamağını sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Gastrik parietal hücrelerin apikal membranında bulunan H/K ATPaz, hidrojen iyonunu mide lümenine salgılar ve potasyumu hücre içine alır. Bu pompa mide asit salgısının son ortak basamağıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.”, “Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.” ve “Soru parietal hücre asit salgısının son basamağını sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle H/K ATPaz en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastanın yakınmaları asit salgısıyla ilişkilidir.

Kanıt 2: Proton pompa inhibitörüyle semptom azalması belirtilmiştir.

Kanıt 3: Soru parietal hücre asit salgısının son basamağını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Mide asit sekresyonunun son ortak basamağı parietal hücre H/K ATPaz pompasıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 312: v194-new-312-dil-hareketiyle-yukselen-boyun-kitlesi

Başlık: Dil hareketiyle yükselen boyun kitlesi

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Tiroglossal kanal kistini orta hat boyun kitlesi ve dil hareketiyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, boyun orta hattında ağrısız şişlik nedeniyle getiriliyor. Ailesi şişliğin uzun süredir olduğunu ve yutkunma sırasında hareket ettiğini belirtmektedir. Son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası hafif hassasiyet gelişmiştir.

Demografi: 12 yaşında kız çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hyoid kemik komşuluğunda orta hatta düzgün sınırlı kistik kitle palpe edilir.
- Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında yukarı hareket eder.
- Tiroid bezi normal yerindedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Boyun ultrasonografisi

Etiket: Boyun ultrasonografisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Orta hatta hyoid komşuluğunda kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Tiroglossal kanal kalıntısı lehinedir. | Sonuç yorumu: Tiroglossal kanal kalıntısı lehinedir. | Sonuç başlığı: Boyun ultrasonografisi | Sonuç özeti: Orta hatta hyoid komşuluğunda kistik lezyon izlendi. | Yorum: Tiroglossal kanal kalıntısı lehinedir. | Satırlar: Boyun ultrasonografisi / Orta hatta hyoid komşuluğunda kistik lezyon izlendi. // Tiroglossal kanal kalıntısı lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-158 | Başlık: Boyun ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Orta hatta hyoid komşuluğunda kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Tiroglossal kanal kalıntısı lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/158_tiroglossal_kanal_kisti_boyun_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/158_tiroglossal_kanal_kisti_boyun_usg.webp | Alt text: Boyun ultrasonografisi - Orta hatta hyoid komşuluğunda kistik lezyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu lezyonun embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tiroglossal kanal kalıntısı
B) İkinci faringeal ark klefti
C) Üçüncü faringeal poş aplazisi
D) Omfalomezenterik kanal kalıntısı
E) Ürakuş kalıntısı

Doğru Cevap: Tiroglossal kanal kalıntısı

- A) Tiroglossal kanal kalıntısı: Tiroglossal kanal kalıntısı tiroid göç yolu üzerinde orta hat kistik kitle oluşturur ve dil hareketiyle yükselir. Vakadaki “Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.” ve “Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.” ipuçları klinik karar açısından Tiroglossal kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) İkinci faringeal ark klefti: İkinci faringeal ark klefti anomalileri genellikle boyun lateralinde kistik lezyon yapar; orta hat-dil hareketi paterni değildir. Bu olguda “Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.” ve “Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.” ipuçları klinik karar açısından Tiroglossal kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Üçüncü faringeal poş aplazisi: Üçüncü faringeal poş aplazisi timus ve paratiroid gelişimiyle ilişkilidir; orta hat boyun kisti yapmaz. Bu olguda “Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.” ve “Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.” ipuçları klinik karar açısından Tiroglossal kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Omfalomezenterik kanal kalıntısı: Omfalomezenterik kanal kalıntısı ileal Meckel divertikülü gibi gastrointestinal anomaliler oluşturur. Bu olguda “Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.” ve “Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.” ipuçları klinik karar açısından Tiroglossal kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Ürakuş kalıntısı: Ürakuş kalıntısı umbilikus ve mesane arasında anomaliler yapar; hyoid komşuluğundaki kitleyle ilişkili değildir. Bu olguda “Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.” ve “Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.” ipuçları klinik karar açısından Tiroglossal kanal kalıntısı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Dil hareketiyle yükselen boyun kitlesi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.” ve “Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.” birlikte okunduğunda Tiroglossal kanal kalıntısı seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide orta hat kistik lezyon izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tiroid bezi foramen cecumdan aşağı inerken tiroglossal kanal boyunca göç eder. Bu kanalın persiste kalıntısı orta hatta, yutkunma ve dil hareketiyle yükselen kistik lezyon oluşturabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.”, “Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.” ve “Ultrasonografide orta hat kistik lezyon izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Tiroglossal kanal kalıntısı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kitle boyun orta hattında ve hyoid komşuluğundadır.

Kanıt 2: Kitle yutkunma ve dil çıkarma sırasında hareket etmektedir.

Kanıt 3: Ultrasonografide orta hat kistik lezyon izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Tiroglossal kanal kisti orta hatta olur ve dil çıkarma ile hareket eder.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 313: v194-new-313-testis-biyopsisinde-destek-hucresi

Başlık: Testis biyopsisinde destek hücresi

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik veriyi hedeflenen karar noktasıyla eşleştirme.

Learning Target: Seminifer tübülde Sertoli hücresinin kan-testis bariyeri ve spermatogenez desteğini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hastada testis biyopsisinde seminifer tübül içindeki destek hücrelerinin işlevi tartışılıyor. Bir yıldır çocuk sahibi olamadığı öğreniliyor. Hormonal değerlendirme ve semen analizi sonrası biyopsi planlanmıştır.

Demografi: 29 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Testis hacimleri hafif küçüktür.
- Varikozel bulgusu belirgin değildir.
- Sekonder cinsiyet özellikleri korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Testis biyopsisi

Etiket: Testis biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Seminifer tübüllerde germ hücreleri arasında uzanan destek hücreleri ve sıkı bağlantılar izlendi. | Klinik anlam: Kan-testis bariyerini oluşturan hücreleri düşündürür. | Sonuç yorumu: Kan-testis bariyerini oluşturan hücreleri düşündürür. | Sonuç başlığı: Testis biyopsisi | Sonuç özeti: Seminifer tübüllerde germ hücreleri arasında uzanan destek hücreleri ve sıkı bağlantılar izlendi. | Yorum: Kan-testis bariyerini oluşturan hücreleri düşündürür. | Satırlar: Testis biyopsisi / Seminifer tübüllerde germ hücreleri arasında uzanan destek hücreleri ve sıkı bağlantılar izlendi. // Kan-testis bariyerini oluşturan hücreleri düşündürür.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-159 | Başlık: Testis biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Seminifer tübüllerde germ hücreleri arasında uzanan destek hücreleri ve sıkı bağlantılar izlendi. | Klinik anlam: Kan-testis bariyerini oluşturan hücreleri düşündürür. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/159_sertoli_hucreleri_seminifer_tubul_histoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/159_sertoli_hucreleri_seminifer_tubul_histoloji.webp | Alt text: Testis biyopsisi - Seminifer tübüllerde germ hücreleri arasında uzanan destek hücreleri ve sıkı bağlantılar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu destek hücresinin temel işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Testosteron sentezi yapmak
- B) Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek
- C) Sperm depolamak
- D) Prostat sıvısı salgılamak
- E) Eritropoietin üretmek

Doğru Cevap: Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek

A) Testosteron sentezi yapmak: Testosteron sentezi interstisyel Leydig hücrelerinin temel işlevidir; Sertoli hücresinin ana görevi değildir. Bu olguda “Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.” ve “Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek: Kan-testis bariyerini oluşturmak ve germ hücrelerini desteklemek Sertoli hücrelerinin temel işlevlerindendir. Vakadaki “Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.” ve “Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Sperm depolamak: Sperm depolama esas olarak epididimisle ilişkilidir; seminifer tübül destek hücresinin ana görevi değildir. Bu olguda “Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.” ve “Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Prostat sıvısı salgılamak: Vakadaki Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir ve Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır. Bu olguda “Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.” ve “Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Eritropoietin üretmek: Eritropoietin üretimi böbrek peritübüler interstisyel hücreleriyle ilişkilidir; testis destek hücresinin görevi değildir. Bu olguda “Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.” ve “Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Testis biyopsisinde destek hücresi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.” ve “Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.” birlikte okunduğunda Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek seçeneği öne çıkar; “Sıkı bağlantılarla ilişkili bariyer yapısı belirtilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sertoli hücreleri seminifer tübüllerde germ hücrelerini destekler, sıkı bağlantılarla kan-testis bariyerini oluşturur ve spermatogenezin uygun mikroçevresini sağlar. Testosteron sentezi ise Leydig hücrelerinin temel işlevidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.”, “Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.” ve “Sıkı bağlantılarla ilişkili bariyer yapısı belirtilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kan-testis bariyerini oluşturmak ve gelişen germ hücrelerini desteklemek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Biyopsi seminifer tübül yapısını değerlendirmektedir.

Kanıt 2: Destek hücreleri germ hücreleri arasında uzanmaktadır.

Kanıt 3: Sıkı bağlantılarla ilişkili bariyer yapısı belirtilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Sertoli hücreleri kan-testis bariyerini kurar; Leydig hücreleri testosteron üretir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 314: v194-new-314-erken-gebelikte-trofoblast-islevi

Başlık: Erken gebelikte trofoblast işlevi

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik veriyi hedeflenen karar noktasıyla eşleştirme.

Learning Target: Plasentada syncytiotrophoblast tabakasını hCG üretimi ve maternal kanla temas üzerinden tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hastada gebeliğin sürdürülmesinde erken dönemde hCG salgılayan plasental hücre tabakası tartışılıyor. Son adet tarihine göre 7 haftalık gebedir. Kan beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu artış göstermektedir. Şikâyeti yoktur.

Demografi: 26 yaşında gebe hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 108/66 mmHg | Nabız: 82/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,76

Fizik Muayene

- Genel görünümü stabil; akut toksik görünüm veya belirgin solunum sıkıntısı izlenmez.
- Pelvik muayenede akut patoloji yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Gebelik testi

Etiket: Gebelik testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Serum beta-hCG pozitif ve gebelik haftasıyla uyumlu saptandı. | Klinik anlam: Trofoblastik hormon üretimini gösterir. | Sonuç yorumu: Trofoblastik hormon üretimini gösterir. | Sonuç başlığı: Gebelik testi | Sonuç özeti: Serum beta-hCG pozitif ve gebelik haftasıyla uyumlu saptandı. | Yorum: Trofoblastik hormon üretimini gösterir. | Satırlar: Gebelik testi / Serum beta-hCG pozitif ve gebelik haftasıyla uyumlu saptandı. // Trofoblastik hormon üretimini gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Maternal kanla doğrudan temas eden ve hCG salgılayan plasental trofoblast tabakası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Cytotrophoblast
- B) Syncytiotrophoblast
- C) Amniyoblast
- D) Epiblast
- E) Hypoblast

Doğru Cevap: Syncytiotrophoblast

A) Cytotrophoblast: Cytotrophoblast proliferatif iç trofoblast tabakasıdır; maternal kanla doğrudan temas eden ana hCG salgılayan tabaka değildir. Bu olguda “Hasta erken gebelik dönemindedir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.” ipuçları klinik karar açısından Syncytiotrophoblast seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Syncytiotrophoblast: Syncytiotrophoblast maternal kanla temas eder ve hCG salgılayarak erken gebeliğin hormonal desteğini sağlar. Vakadaki “Hasta erken gebelik dönemindedir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

C) Amniyoblast: Amniyoblast amniyon boşluğu ve amniyon gelişimiyle ilişkilidir; hCG salgılayan trofoblast tabakası değildir. Bu olguda “Hasta erken gebelik dönemindedir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.” ipuçları klinik karar açısından Syncytiotrophoblast seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Epiblast: Vakadaki Hasta erken gebelik dönemindedir ve Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir. Bu olguda “Hasta erken gebelik dönemindedir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.” ipuçları klinik karar açısından Syncytiotrophoblast seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hypoblast: Hypoblast yolk sac gelişimiyle ilişkilidir; maternal kanla temas eden trofoblast tabakası değildir. Bu olguda “Hasta erken gebelik dönemindedir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.” ipuçları klinik karar açısından Syncytiotrophoblast seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken gebelikte trofoblast işlevi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hasta erken gebelik dönemindedir.” ve “Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.” birlikte okunduğunda Syncytiotrophoblast seçeneği öne çıkar; “Soru maternal kanla temas eden trofoblast tabakasını sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Syncytiotrophoblast maternal kanla temas eden dış trofoblast tabakasıdır ve erken gebelikte hCG salgılayarak korpus luteumun devamını destekler. Cytotrophoblast ise daha içte yer alan proliferatif hücre tabakasıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta erken gebelik dönemindedir.”, “Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.” ve “Soru maternal kanla temas eden trofoblast tabakasını sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Syncytiotrophoblast en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta erken gebelik dönemindedir.

Kanıt 2: Serum beta-hCG düzeyi gebelikte uyumlu pozitifdir.

Kanıt 3: Soru maternal kanla temas eden trofoblast tabakasını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: hCG salgılayan ve maternal kanla temas eden ana trofoblast tabakası syncytiotrophoblasttır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 315: v194-new-315-meyve-puresi-sonrasi-kusma-ve-hipoglisemi

Başlık: Meyve püresi sonrası kusma ve hipoglisemi

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Herediter fruktoz intoleransında aldolaz B eksikliğini hipoglisemi ve karaciğer bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, meyve püresi başladıktan sonra kusma, terleme ve halsizlik atakları nedeniyle getiriliyor. Anne sütüyle belirgin sorun yaşamadığı, ek gıdaya meyve püresi ve meyve suyu eklendikten sonra beslenme sonrası huzursuzluk, kusma ve uykuya eğilim geliştiği öğreniliyor.

Demografi: 7 aylık kız bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebek hafif hepatomegaliktir.
- Atak sırasında soluk ve terli görünmektedir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Beslenme sonrası hipoglisemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Beslenme sonrası hipoglisemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Beslenme sonrası hipoglisemiyi gösterir. | Satırlar: Kan glukozu / 42 mg/dL / 70-100 mg/dL / Beslenme sonrası hipoglisemiyi gösterir.

Tetkik 2: Karaciğer enzimleri

Etiket: Karaciğer enzimleri | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hepatik etkilenimi destekler. | Sonuç yorumu: Hepatik etkilenimi destekler. | Sonuç başlığı: Karaciğer enzimleri | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hepatik etkilenimi destekler. | Satırlar: Karaciğer enzimleri / Yüksek saptandı. / / Hepatik etkilenimi destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki en olası enzim defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aldolaz B eksikliği
B) Laktaz eksikliği
C) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği
D) Homogentizat oksidaz eksikliği
E) Heksozaminidaz A eksikliği

Doğru Cevap: Aldolaz B eksikliği

A) Aldolaz B eksikliği: Aldolaz B eksikliği fruktoz alımı sonrası hipoglisemi ve hepatik hasar tablosunu açıklar. Vakadaki “Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.” ve “Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Laktaz eksikliği: Laktaz eksikliği süt ürünleri sonrası osmotik ishal ve gaz yapar; hipoglisemi-hepatomegali beklenmez. Bu olguda “Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.” ve “Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Aldolaz B eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Fenilalanin hidroksilaz eksikliği: Fenilalanin hidroksilaz eksikliği fenilketonüriye yol açar; fruktoz alımıyla tetiklenen hipoglisemiyi açıklamaz. Bu olguda “Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.” ve “Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Aldolaz B eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Homogentizat oksidaz eksikliği: Homogentizat oksidaz eksikliği alkaptonüri yapar; bebekte fruktozla kusma ve hipoglisemi beklenmez. Bu olguda “Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.” ve “Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Aldolaz B eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Heksozaminidaz A eksikliği: Heksozaminidaz A eksikliği Tay-Sachs hastalığıyla ilişkilidir; fruktoz metabolizması bozukluğu değildir. Bu olguda “Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.” ve “Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Aldolaz B eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Meyve püresi sonrası kusma ve hipoglisemi olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.” ve “Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Aldolaz B eksikliği seçeneği öne çıkar; “Hepatomegali ve karaciğer enzim yüksekliği vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Fruktoz içeren gıdalarla başlayan kusma, hipoglisemi ve hepatik etkilenim herediter fruktoz intoleransını düşündürür. Aldolaz B eksikliğinde fruktoz-1-fosfat birikir, fosfat tuzaklanır ve glukoneogenez ile glikojenoliz bozulur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.”, “Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.” ve “Hepatomegali ve karaciğer enzim yüksekliği vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Aldolaz B eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Semptomlar meyve püresi ve meyve suyu başlanmasından sonra gelişmiştir.

Kanıt 2: Atak sırasında hipoglisemi saptanmıştır.

Kanıt 3: Hepatomegali ve karaciğer enzim yüksekliği vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Herediter fruktoz intoleransında aldolaz B eksiktir; fruktozdan kaçınma temel yaklaşımdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 316: v194-new-316-gunesle-artan-dokuntu-ve-ataksi

Başlık: Güneşle artan döküntü ve ataksi

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Hartnup hastalığında nötral aminoasit taşıyıcı bozukluğunu pellagra benzeri bulgularla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, güneşle artan döküntü, aralıklı ataksi ve davranış değişikliği nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun özellikle yaz aylarında yüz ve ellerde döküntü geliştirdiğini, bazı dönemlerde dengesiz yürüdüğünü ve okul başarısının dalgalandığını belirtmektedir.

Demografi: 10 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Güneş gören alanlarda eritemli dermatit vardır.
- Hafif ataksik yürüyüş izlenir.
- Karaciğer ve dalak büyüklüğü saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar aminoasit analizi

Etiket: İdrar aminoasit analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nötral aminoasit atılımında artış saptandı. | Klinik anlam: Hartnup hastalığını destekler. | Sonuç yorumu: Hartnup hastalığını destekler. | Sonuç başlığı: İdrar aminoasit analizi | Sonuç özeti: Nötral aminoasit atılımında artış saptandı. | Yorum: Hartnup hastalığını destekler. | Satırlar: İdrar aminoasit analizi / Nötral aminoasit atılımında artış saptandı. // Hartnup hastalığını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel biyokimyasal bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk
- B) Dalı zincirli aminoasitlerin oksidatif dekarboksilasyonunda bozukluk
- C) Fruktoz-1-fosfatın parçalanmasında bozukluk
- D) Bakırın safra ile atılımında bozukluk
- E) Pürin kurtarma yolunda hipoksantin kullanımında bozukluk

Doğru Cevap: Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk

A) Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk: Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk Hartnup hastalığını ve pellagra benzeri bulguları açıklar. Vakadaki "Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir." ve "Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Dalı zincirli aminoasitlerin oksidatif dekarboksilasyonunda bozukluk: Dalı zincirli aminoasitlerin oksidatif dekarboksilasyon bozukluğu akçaağaç şurubu idrar hastalığına neden olur. Bu olguda "Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir." ve "Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir." ipuçları klinik karar açısından Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Fruktoz-1-fosfatın parçalanmasında bozukluk: Fruktoz-1-fosfat yıkım bozukluğu hereditör fruktoz intoleransında görülür; fotosensitif pellagra benzeri tabloyu açıklamaz. Bu olguda "Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir." ve "Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir." ipuçları klinik karar açısından Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Bakırın safra ile atılımında bozukluk: Bakırın safra ile atılım bozukluğu Wilson hastalığıyla ilişkilidir; nötral aminoasit atılımını açıklamaz. Bu olguda "Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir." ve "Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir." ipuçları klinik karar açısından Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Pürin kurtarma yolunda hipoksantin kullanımında bozukluk: Vakadaki Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir ve Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir. Bu olguda "Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir." ve "Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir." ipuçları klinik karar açısından Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Güneşle artan döküntü ve ataksi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir." ve "Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk seçeneği öne çıkar; "İdrarda nötral aminoasit atılımı artmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hartnup hastalığında triptofan gibi nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşınması bozulur. Triptofan niasin öncülü olduğundan pellagra benzeri fotosensitif dermatit, nörolojik bulgular ve davranış değişiklikleri gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir.", "Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir." ve "İdrarda nötral aminoasit atılımı artmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nötral aminoasitlerin bağırsak ve böbrek taşıyıcısında bozukluk en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Döküntüler güneş gören alanlarda belirginleşmektedir.

Kanıt 2: Ataksi ve davranış değişikliği eşlik etmektedir.

Kanıt 3: İdrarda nötral aminoasit atılımı artmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Hartnup hastalığı nötral aminoasit taşıyıcı bozukluğudur ve pellagra benzeri bulgular yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 317: v194-new-317-genc-hastada-karaciger-ve-hareket-bulgulari

Başlık: Genç hastada karaciğer ve hareket bulguları

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Wilson hastalığında ATP7B bozukluğunu bakır birikimi ve Kayser-Fleischer halkasıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, karaciğer enzim yüksekliği, titreme ve davranış değişikliği nedeniyle başvuruyor. Son aylarda okul başarısında düşme, iritabilite ve ellerde titreme geliştiği öğreniliyor. Ailede genç yaşta açıklanamayan karaciğer hastalığı öyküsü vardır.

Demografi: 17 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Muayenede hafif tremor ve distoni izlenir.
- Göz muayenesinde korneal Kayser-Fleischer halkası bildirilmiştir.
- Hafif hepatomegali vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum serüloplazmin

Etiket: Serum serüloplazmin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Bakır metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Bakır metabolizması bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Serum serüloplazmin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Bakır metabolizması bozukluğunu destekler. | Satırlar: Serum serüloplazmin / Düşük saptandı. // Bakır metabolizması bozukluğunu destekler.

Tetkik 2: 24 saatlik idrar bakır atılımı

Etiket: 24 saatlik idrar bakır atılımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Wilson hastalığı lehinedir. | Sonuç yorumu: Wilson hastalığı lehinedir. | Sonuç başlığı: 24 saatlik idrar bakır atılımı | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Wilson hastalığı lehinedir. | Satırlar: 24 saatlik idrar bakır atılımı / Yüksek saptandı. // Wilson hastalığı lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel moleküler bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk
B) Heksozaminidaz A aracılı GM2 yıkımında bozukluk
C) Aldolaz B aracılı fruktoz yıkımında bozukluk
D) Fenilalanin hidroksilaz aracılı tirozin üretiminde bozukluk
E) Homogentizat oksidaz aracılı tirozin katabolizmasında bozukluk

Doğru Cevap: ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk

A) ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk: ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılım bozukluğu Wilson hastalığının temel mekanizmasıdır. Vakadaki "Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır." ve "Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Heksozaminidaz A aracılı GM2 yıkımında bozukluk: Heksozaminidaz A eksikliği Tay-Sachs hastalığına neden olur; bakır metabolizmasıyla ilişkili değildir. Bu olguda "Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır." ve "Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Aldolaz B aracılı fruktoz yıkımında bozukluk: Aldolaz B eksikliği hereditör fruktoz intoleransına neden olur; Kayser-Fleischer halkasını açıklamaz. Bu olguda "Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır." ve "Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Fenilalanin hidroksilaz aracılı tirozin üretiminde bozukluk: Vakadaki Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır ve Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır. Bu olguda "Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır." ve "Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Homogentizat oksidaz aracılı tirozin katabolizmasında bozukluk: Homogentizat oksidaz eksikliği alkaptonüriye yol açar; serüloplazmin düşüklüğüyle ilişkili değildir. Bu olguda "Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır." ve "Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Genç hastada karaciğer ve hareket bulguları olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır." ve "Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır." birlikte okunduğunda ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk seçeneği öne çıkar; "Serüloplazmin düşük ve idrar bakır atılımı yüksek bulunmuştur." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Wilson hastalığında ATP7B mutasyonu hepatositlerde bakırın serüloplazmine bağlanmasını ve safra yoluyla atılmasını bozar. Bakır karaciğer, beyin ve korneada birikerek hepatik, nöropsikiyatrik bulgular ve Kayser-Fleischer halkası oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır.", "Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır." ve "Serüloplazmin düşük ve idrar bakır atılımı yüksek bulunmuştur." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle ATP7B aracılı hepatik bakır taşınması ve safra atılımında bozukluk en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada karaciğer ve nöropsikiyatrik bulgular birlikte vardır.

Kanıt 2: Kayser-Fleischer halkası saptanmıştır.

Kanıt 3: Serüloplazmin düşük ve idrar bakır atılımı yüksek bulunmuştur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Wilson hastalığı ATP7B bozukluğuna bağlı bakır birikimidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 318: v194-new-318-sel-sonrasi-ates-ve-sarilik

Başlık: Sel sonrası ateş ve sarılık

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Leptospira enfeksiyonunu sarılık, böbrek yetmezliği ve kemirgen idrarı maruziyetiyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yüksek ateş, baldır ağrısı, sarılık ve idrar miktarında azalma nedeniyle başvuruyor. Bir hafta önce sel temizliği sırasında kirli suyla temas ettiği ve çizme kullanmadığı öğreniliyor. Sonrasında ateş, baş ağrısı ve yaygın kas ağrıları başlamıştır.

Demografi: 35 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,12 (yüksek)

Fizik Muayene

- Skleralar ikteriktir.
- Baldır kaslarında belirgin hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Böbrek etkilenimini destekler. | Sonuç yorumu: Böbrek etkilenimini destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Böbrek etkilenimini destekler. | Satırlar: Serum kreatinin / 2.6 mg/dL / 0.6-1.2 mg/dL / Böbrek etkilenimini destekler.

Tetkik 2: Total bilirubin

Etiket: Total bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Sarılık tablosunu destekler. | Sonuç yorumu: Sarılık tablosunu destekler. | Sonuç başlığı: Total bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Sarılık tablosunu destekler. | Satırlar: Total bilirubin / 7.4 mg/dL / 0.2-1.2 mg/dL / Sarılık tablosunu destekler.

Tetkik 3: Mikroskopik aglütinasyon testi

Etiket: Mikroskopik aglütinasyon testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Leptospira için pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni destekler. | Sonuç yorumu: Etkeni destekler. | Sonuç başlığı: Mikroskopik aglütinasyon testi | Sonuç özeti: Leptospira için pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni destekler. | Satırlar: Mikroskopik aglütinasyon testi / Leptospira için pozitif saptandı. // Etkeni destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Leptospira interrogans
B) Borrelia burgdorferi
C) Treponema pallidum
D) Rickettsia rickettsii
E) Mycoplasma pneumoniae

Doğru Cevap: Leptospira interrogans

- A) Leptospira interrogans: Leptospira interrogans kirli su maruziyeti sonrası sarılık, böbrek yetmezliği ve baldır ağrısıyla en uyumlu etkindir. Vakadaki "Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir." ve "Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Borrelia burgdorferi: Vakadaki Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir ve Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir. Bu olguda "Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir." ve "Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir." ipuçları tanısallık karar açısından Leptospira interrogans seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Treponema pallidum: Treponema pallidum sifiliz etkenidir; sel sonrası sarılık-böbrek yetmezliği paternini açıklamaz. Bu olguda "Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir." ve "Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir." ipuçları tanısallık karar açısından Leptospira interrogans seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Rickettsia rickettsii: Rickettsia rickettsii kayalık dağlar benekli ateşiyle ilişkilidir; kemirgen idrarı ve Weil tablosu tipik değildir. Bu olguda "Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir." ve "Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir." ipuçları tanısallık karar açısından Leptospira interrogans seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Mycoplasma pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae atipik pnömoni etkenidir; sarılık ve böbrek yetmezliğiyle seyreden bu tabloyu açıklamaz. Bu olguda "Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir." ve "Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir." ipuçları tanısallık karar açısından Leptospira interrogans seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sel sonrası ateş ve sarılık olgusunda klinik karar tanısallık karar üzerine kuruludur. "Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir." ve "Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir." birlikte okunduğunda Leptospira interrogans seçeneği öne çıkar; "Baldır kaslarında belirgin hassasiyet vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kirli su ve kemirgen idrarı maruziyeti sonrası ateş, baldır ağrısı, sarılık ve böbrek yetmezliği Weil hastalığı olarak bilinen ağır leptospiroz tablosunu düşündürür. Etken ince spiral yapılı Leptospira interrogans'tır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir.", "Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir." ve "Baldır kaslarında belirgin hassasiyet vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Leptospira interrogans en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta sel sonrası kirli suyla temas etmiştir.

Kanıt 2: Sarılık ve böbrek yetmezliği birlikte gelişmiştir.

Kanıt 3: Baldır kaslarında belirgin hassasiyet vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Leptospirozda baldır ağrısı, sarılık ve böbrek yetmezliği klasik ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 319: v194-new-319-magara-gezisi-sonrasi-ates-ve-oksuruk

Başlık: Mağara gezisi sonrası ateş ve öksürük

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Histoplasma capsulatum enfeksiyonunu mağara-yarasa maruziyeti ve makrofaj içi maya ile tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ateş, kuru öksürük ve halsizlik nedeniyle başvuruyor. Üç hafta önce yarasa dışkısının yoğun olduğu bir mağarada gezdiği öğreniliyor. Sonrasında düşük ateş, öksürük ve göğüs rahatsızlığı gelişmiştir.

Demografi: 28 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.0°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Akciğerlerde hafif raller duyulur.
- Hepatosplenomegali yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Bilateral küçük nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Klinik anlam: Granülatöz mantar enfeksiyonunu destekleyebilir. | Sonuç yorumu: Granülatöz mantar enfeksiyonunu destekleyebilir. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Bilateral küçük nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Yorum: Granülatöz mantar enfeksiyonunu destekleyebilir. | Satırlar: Akciğer grafisi / Bilateral küçük nodüler infiltrasyonlar izlendi. // Granülatöz mantar enfeksiyonunu destekleyebilir.

Tetkik 2: Balgam sitolojisi

Etiket: Balgam sitolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Makrofajlar içinde küçük oval maya formları izlendi. | Klinik anlam: Histoplasma enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Histoplasma enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Balgam sitolojisi | Sonuç özeti: Makrofajlar içinde küçük oval maya formları izlendi. | Yorum: Histoplasma enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Balgam sitolojisi / Makrofajlar içinde küçük oval maya formları izlendi. // Histoplasma enfeksiyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-160 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Bilateral küçük nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Klinik anlam: Granülatöz mantar enfeksiyonunu destekleyebilir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/160_histoplazmoz_noduler_infiltrasyon_akciger_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/160_histoplazmoz_noduler_infiltrasyon_akciger_grafisi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Bilateral küçük nodüler infiltrasyonlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-161 | Başlık: Balgam sitolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Makrofajlar içinde küçük oval maya formları izlendi. | Klinik anlam: Histoplasma enfeksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/161_histoplasma_makrofaj_icinde_maya_sitoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/161_histoplasma_makrofaj_icinde_maya_sitoloji.webp | Alt text: Balgam sitolojisi - Makrofajlar içinde küçük oval maya formları izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mantar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Histoplasma capsulatum
- B) Candida albicans
- C) Aspergillus fumigatus
- D) Cryptococcus neoformans
- E) Mucor türleri

Doğru Cevap: Histoplasma capsulatum

A) Histoplasma capsulatum: Histoplasma capsulatum mağara-yarasa dışkısı maruziyeti ve makrofaj içi küçük maya formlarıyla en uyumlu etkindir. Vakadaki “Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.” ve “Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Candida albicans: Candida albicans genellikle mukokutanöz enfeksiyon ve psödohipilerle ilişkilidir; makrofaj içi küçük maya paterni tipik değildir. Bu olguda “Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.” ve “Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Histoplasma capsulatum seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Aspergillus fumigatus: Aspergillus fumigatus septalı hifler ve dar açılı dallanma ile tanınır; makrofaj içi maya değildir. Bu olguda “Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.” ve “Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Histoplasma capsulatum seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Cryptococcus neoformans: Vakadaki Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır ve Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır. Bu olguda “Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.” ve “Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Histoplasma capsulatum seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Mucor türleri: Vakadaki Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır ve Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır. Bu olguda “Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.” ve “Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Histoplasma capsulatum seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Mağara gezisi sonrası ateş ve öksürük olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.” ve “Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.” birlikte okunduğunda Histoplasma capsulatum seçeneği öne çıkar; “Sitojide makrofaj içinde küçük maya formları izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yarasa veya kuş dışkısı içeren mağara maruziyeti sonrası akciğer bulguları ve makrofaj içinde küçük maya formları Histoplasma capsulatum enfeksiyonunu düşündürür. Bu dimorfik mantar retiküloendotelial sistemi tutabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.”, “Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.” ve “Sitojide makrofaj içinde küçük maya formları izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Histoplasma capsulatum en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta yarasa dışkısı bulunan mağaraya maruz kalmıştır.

Kanıt 2: Akciğer grafisinde nodüler infiltrasyonlar vardır.

Kanıt 3: Sitojide makrofaj içinde küçük maya formları izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Histoplasma capsulatum makrofaj içinde yaşayan küçük maya formlarıyla tanınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 320: v194-new-320-karacigerde-kistik-lezyon

Başlık: Karaciğerde kistik lezyon

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Echinococcus granulosus enfeksiyonunu hidatik kist ve köpek-koyun döngüsüyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ üst kadranda dolgunluğu ve karaciğerde kistik lezyon nedeniyle başvuruyor. Kırsal bölgede yaşadığı, koyun yetiştirdiği ve köpeklerle yakın teması olduğu öğreniliyor. Ateş veya akut sarılık tariflememektedir.

Demografi: 43 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ üst kadranda hafif dolgunluk hissi vardır.
- Akut batin bulgusu yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Karaciğer sağ lobda kız veziküller içeren büyük kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Hidatik kist lehinedir. | Sonuç yorumu: Hidatik kist lehinedir. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Karaciğer sağ lobda kız veziküller içeren büyük kistik lezyon izlendi. | Yorum: Hidatik kist lehinedir. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Karaciğer sağ lobda kız veziküller içeren büyük kistik lezyon izlendi. / / Hidatik kist lehinedir.

Tetkik 2: Serolojik test

Etiket: Serolojik test | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Echinococcus için pozitif saptandı. | Klinik anlam: Etkeni destekler. | Sonuç yorumu: Etkeni destekler. | Sonuç başlığı: Serolojik test | Sonuç özeti: Echinococcus için pozitif saptandı. | Yorum: Etkeni destekler. | Satırlar: Serolojik test / Echinococcus için pozitif saptandı. / / Etkeni destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-162 | Başlık: Abdominal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Karaciğer sağ lobda kız veziküller içeren büyük kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Hidatik kist lehinedir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/162_hidatik_kist_karaciger_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/162_hidatik_kist_karaciger_usg.webp | Alt text: Abdominal ultrasonografi - Karaciğer sağ lobda kız veziküller içeren büyük kistik lezyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Echinococcus granulosus
B) Taenia saginata
C) Enterobius vermicularis
D) Ascaris lumbricoides
E) Trichuris trichiura

Doğru Cevap: Echinococcus granulosus

- A) Echinococcus granulosus: Echinococcus granulosus karaciğerde hidatik kist ve köpek-koyun maruziyetiyle en uyumlu parazittir. Vakadaki “Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.” ve “Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Taenia saginata: Taenia saginata sığır etiyile bulaşan erişkin barsak tenyasıdır; kız veziküllü karaciğer kisti tipik değildir. Bu olguda “Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.” ve “Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Echinococcus granulosus seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Enterobius vermicularis: Vakadaki Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir ve Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır. Bu olguda “Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.” ve “Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Echinococcus granulosus seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Ascaris lumbricoides: Vakadaki Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir ve Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır. Bu olguda “Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.” ve “Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Echinococcus granulosus seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Trichuris trichiura: Vakadaki Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir ve Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır. Bu olguda “Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.” ve “Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Echinococcus granulosus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Karaciğerde kistik lezyon olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.” ve “Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.” birlikte okunduğunda Echinococcus granulosus seçeneği öne çıkar; “Echinococcus serolojisi pozitifdir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Köpek-koyun döngüsüyle ilişkili kırsal maruziyet, karaciğerde kız veziküllü kistik lezyon ve pozitif seroloji kistik ekinokokkozisi düşündürür. Etken Echinococcus granulosus’tur. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.”, “Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.” ve “Echinococcus serolojisi pozitifdir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Echinococcus granulosus en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta koyun yetiştiriciliği ve köpek teması bildirmektedir.

Kanıt 2: Karaciğerde kız veziküller içeren kistik lezyon vardır.

Kanıt 3: Echinococcus serolojisi pozitifdir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Hidatik kistte köpek kesin konak, koyun ara konak; insan rastlantısal ara konaktır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 321: v194-new-321-kanli-ishal-ve-rektumdan-baslayan-tutulum

Başlık: Kanlı ishal ve rektumdan başlayan tutulum

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Ülseratif kolitte sürekli mukozal tutulum ve kript apselerini Crohn hastalığından ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tekrarlayan kanlı ishal, karın ağrısı ve dışkılama aciliyeti nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık altı aydır ataklar halinde kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus yaşadığını belirtmektedir. Perianal fistül öyküsü yoktur.

Demografi: 34 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Karında sol alt kadranda hafif hassasiyet vardır.
- Perianal muayenede fistül veya apse saptanmaz.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kolonoskopi

Etiket: Kolonoskopi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Rektumdan başlayıp proksimale doğru kesintisiz uzanan eritemli ve fragil mukoza izlendi. | Klinik anlam: Ülseratif kolit lehinedir. | Sonuç yorumu: Ülseratif kolit lehinedir. | Sonuç başlığı: Kolonoskopi | Sonuç özeti: Rektumdan başlayıp proksimale doğru kesintisiz uzanan eritemli ve fragil mukoza izlendi. | Yorum: Ülseratif kolit lehinedir. | Satırlar: Kolonoskopi / Rektumdan başlayıp proksimale doğru kesintisiz uzanan eritemli ve fragil mukoza izlendi. // Ülseratif kolit lehinedir.

Tetkik 2: Kolon biyopsisi

Etiket: Kolon biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Mukozada kript apseleri ve kronik inflamasyon izlendi. | Klinik anlam: Ülseratif kolit paternini destekler. | Sonuç yorumu: Ülseratif kolit paternini destekler. | Sonuç başlığı: Kolon biyopsisi | Sonuç özeti: Mukozada kript apseleri ve kronik inflamasyon izlendi. | Yorum: Ülseratif kolit paternini destekler. | Satırlar: Kolon biyopsisi / Mukozada kript apseleri ve kronik inflamasyon izlendi. // Ülseratif kolit paternini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-163 | Başlık: Kolonoskopi | Modalite: endoscopy | Bulgu: Rektumdan başlayıp proksimale doğru kesintisiz uzanan eritemli ve fragil mukoza izlendi. | Klinik anlam: Ülseratif kolit lehinedir. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/163_ulseratif_kolit_kolonoskopi.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/163_ulseratif_kolit_kolonoskopi.webp | Alt text: Kolonoskopi - Rektumdan başlayıp proksimale doğru kesintisiz uzanan eritemli ve fragil mukoza izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-164 | Başlık: Kolon biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Mukozada kript apseleri ve kronik inflamasyon izlendi. | Klinik anlam: Ülseratif kolit paternini destekler. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/164_ulseratif_kolit_kript_apsesi_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/164_ulseratif_kolit_kript_apsesi_histopatoloji.webp | Alt text: Kolon biyopsisi - Mukozada kript apseleri ve kronik inflamasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ülseratif kolit
B) Crohn hastalığı
C) İskemik kolit
D) Pseudomembranöz kolit
E) İrritabl bağırsak sendromu

Doğru Cevap: Ülseratif kolit

- A) Ülseratif kolit: Ülseratif kolit rektumdan başlayan kesintisiz mukozal inflamasyon ve kript apseleriyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.” ve “Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Crohn hastalığı: Crohn hastalığında atlamalı lezyonlar, transmural inflamasyon ve fistül eğilimi beklenir; bu hastada kesintisiz rektal tutulum vardır. Bu olguda “Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.” ve “Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Ülseratif kolit seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) İskemik kolit: İskemik kolit genellikle yaşlı veya vasküler riskli hastada ani ağır-kanama ile seyreder; kronik rektal kesintisiz tutulum beklenmez. Bu olguda “Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.” ve “Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Ülseratif kolit seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Pseudomembranöz kolit: Pseudomembranöz kolit antibiyotik sonrası psödömembranlarla ilişkilidir; burada kript apseli kronik inflamatuvar barsak hastalığı paterni vardır. Bu olguda “Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.” ve “Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Ülseratif kolit seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) İrritabl bağırsak sendromu: Vakadaki Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır ve Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir. Bu olguda “Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.” ve “Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Ülseratif kolit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kanlı ishal ve rektumdan başlayan tutulum olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.” ve “Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Ülseratif kolit seçeneği öne çıkar; “Biyopside kript apseleri saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Rektumdan başlayan kesintisiz mukozal tutulum, kanlı mukuslu ishal, tenesmus ve kript apseleri ülseratif koliti düşündürür. Crohn hastalığında atlamalı transmural tutulum ve fistül daha tipiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.”, “Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.” ve “Biyopside kript apseleri saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ülseratif kolit en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Kanlı mukuslu dışkılama ve tenesmus vardır.

Kanıt 2: Kolonoskopide rektumdan başlayan kesintisiz tutulum izlenmiştir.

Kanıt 3: Biyopside kript apseleri saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayrılar.

Exam Pearl: Ülseratif kolit rektumdan başlar, kesintisiz ilerler ve mukozal tutulum gösterir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 322: v194-new-322-farenjit-sonrasi-eklem-agrisi-ve-kardit

Başlık: Farenjit sonrası eklem ağrısı ve kardit

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Akut romatizmal ateşte Aschoff cisimciğini ve pankardit riskini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, gezici eklem ağrısı ve çarpıntı nedeniyle getiriliyor. Üç hafta önce tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu geçirdiği, son günlerde diz ve ayak bileklerinde sırayla ağrı-şişlik yaşadığı öğreniliyor.

Demografi: 13 yaşında kız çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.0°C | Şok indeksi: 1,08 (yüksek)

Fizik Muayene

- Apeks bölgesinde yeni gelişen üfürüm duyulur.
- Dizde hafif şişlik vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Antistreptolizin O titresi

Etiket: Antistreptolizin O titresi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Yakın dönem streptokok enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Yakın dönem streptokok enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Antistreptolizin O titresi | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Yakın dönem streptokok enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Antistreptolizin O titresi / Yüksek saptandı. // Yakın dönem streptokok enfeksiyonunu destekler.

Tetkik 2: Endomiyokardiyal histoloji bilgisi

Etiket: Endomiyokardiyal histoloji bilgisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Anitschkow hücreleri içeren Aschoff cisimcikleri tanımlandı. | Klinik anlam: Romatizmal kardit için karakteristiktir. | Sonuç yorumu: Romatizmal kardit için karakteristiktir. | Sonuç başlığı: Endomiyokardiyal histoloji bilgisi | Sonuç özeti: Anitschkow hücreleri içeren Aschoff cisimcikleri tanımlandı. | Yorum: Romatizmal kardit için karakteristiktir. | Satırlar: Endomiyokardiyal histoloji bilgisi / Anitschkow hücreleri içeren Aschoff cisimcikleri tanımlandı. // Romatizmal kardit için karakteristiktir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-165 | Başlık: Endomiyokardiyal histoloji bilgisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Anitschkow hücreleri içeren Aschoff cisimcikleri tanımlandı. | Klinik anlam: Romatizmal kardit için karakteristiktir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/165_aschoff_cisimcigi_miyokard_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/165_aschoff_cisimcigi_miyokard_histopatoloji.webp | Alt text: Endomiyokardiyal histoloji bilgisi - Anitschkow hücreleri içeren Aschoff cisimcikleri tanımlandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki karakteristik kardiyak histopatolojik lezyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aschoff cisimciği
B) Kazeifiye granülom
C) Psammoma cisimciği
D) Mallory-Denk cisimciği
E) Councilman cisimciği

Doğru Cevap: Aschoff cisimciği

- A) Aschoff cisimciği: Aschoff cisimciği akut romatizmal ateş karditinin karakteristik histopatolojik lezyonudur. Vakadaki “Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.” ve “Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) Kazeifiye granülom: Kazeifiye granülom tüberküloz gibi enfeksiyonlarda beklenir; romatizmal karditin tipik lezyonu değildir. Bu olguda “Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.” ve “Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Aschoff cisimciği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Psammoma cisimciği: Psammoma cisimciği papiller tümörler gibi kalsifik yapılarla ilişkilidir; romatizmal ateş bulgusu değildir. Bu olguda “Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.” ve “Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Aschoff cisimciği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Mallory-Denk cisimciği: Vakadaki Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır ve Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir. Bu olguda “Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.” ve “Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Aschoff cisimciği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Councilman cisimciği: Councilman cisimciği viral hepatitte apoptotik hepatositleri ifade eder; kardit lezyonu değildir. Bu olguda “Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.” ve “Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.” ipuçları klinik karar açısından Aschoff cisimciği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Farenjit sonrası eklem ağrısı ve kardit olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.” ve “Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Aschoff cisimciği seçeneği öne çıkar; “Antistreptolizin O titresi yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tedavi edilmemiş grup A streptokok farenjiti sonrası gelişen gezici poliartrit ve kardit akut romatizmal ateşi düşündürür. Kalpte Anitschkow hücreleri içeren Aschoff cisimcikleri karakteristik lezyondur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.”, “Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.” ve “Antistreptolizin O titresi yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Aschoff cisimciği en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada yakın zamanda tedavi edilmemiş boğaz enfeksiyonu vardır.

Kanıt 2: Gezici eklem bulguları ve yeni üfürüm gelişmiştir.

Kanıt 3: Antistreptolizin O titresi yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Akut romatizmal ateşte Aschoff cisimcikleri ve Anitschkow hücreleri klasik patoloji bulgusudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 323: v194-new-323-ergende-diz-cevresinde-agrili-kitle

Başlık: Ergende diz çevresinde ağırlı kitle

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Osteosarkomda metafiz yerleşimi, osteoid üretimi ve radyolojik periost reaksiyonunu tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, diz çevresinde giderek artan ağrı ve şişlik nedeniyle başvuruyor. Ağrının birkaç aydır devam ettiği, geceleri arttığı ve son haftalarda distal femur çevresinde şişlik fark edildiği öğreniliyor. Travma öyküsü yoktur.

Demografi: 16 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Distal femur metafiz bölgesinde hassas, sert şişlik vardır.
- Diz hareketleri ağrılıdır.
- Ateş yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Femur grafisi

Etiket: Femur grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Distal femur metafizinde agresif kemik lezyonu, güneş ışını tarzı periost reaksiyonu ve Codman üçgeni izlendi. | Klinik anlam: Osteosarkom lehinedir. | Sonuç yorumu: Osteosarkom lehinedir. | Sonuç başlığı: Femur grafisi | Sonuç özeti: Distal femur metafizinde agresif kemik lezyonu, güneş ışını tarzı periost reaksiyonu ve Codman üçgeni izlendi. | Yorum: Osteosarkom lehinedir. | Satırlar: Femur grafisi | Distal femur metafizinde agresif kemik lezyonu, güneş ışını tarzı periost reaksiyonu ve Codman üçgeni izlendi. // Osteosarkom lehinedir.

Tetkik 2: Biyopsi histopatolojisi

Etiket: Biyopsi histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Atipik malign hücreler tarafından üretilen osteoid izlendi. | Klinik anlam: Osteosarkom için tanısaldır. | Sonuç yorumu: Osteosarkom için tanısaldır. | Sonuç başlığı: Biyopsi histopatolojisi | Sonuç özeti: Atipik malign hücreler tarafından üretilen osteoid izlendi. | Yorum: Osteosarkom için tanısaldır. | Satırlar: Biyopsi histopatolojisi | Atipik malign hücreler tarafından üretilen osteoid izlendi. // Osteosarkom için tanısaldır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-166 | Başlık: Femur grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Distal femur metafizinde agresif kemik lezyonu, güneş ışını tarzı periost reaksiyonu ve Codman üçgeni izlendi. | Klinik anlam: Osteosarkom lehinedir. | URL: https://iukbtlkxictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/166_osteosarkom_distal_femur_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkxictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/166_osteosarkom_distal_femur_grafisi.webp | Alt text: Femur grafisi - Distal femur metafizinde agresif kemik lezyonu, güneş ışını tarzı periost reaksiyonu ve Codman üçgeni izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-167 | Başlık: Biyopsi histopatolojisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Atipik malign hücreler tarafından üretilen osteoid izlendi. | Klinik anlam: Osteosarkom için tanısaldır. | URL: https://iukbtlkxictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/167_osteosarkom_osteoid_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkxictqdsd.public.blob.vercel-storage.com/167_osteosarkom_osteoid_histopatoloji.webp | Alt text: Biyopsi histopatolojisi - Atipik malign hücreler tarafından üretilen osteoid izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Osteosarkom
B) Ewing sarkomu
C) Osteoid osteom
D) Kondrosarkom
E) Multipl miyelom

Doğru Cevap: Osteosarkom

- A) Osteosarkom: Osteosarkom metafiz yerleşimi, agresif periost reaksiyonu ve malign osteoid üretimiyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.” ve “Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Ewing sarkomu: Ewing sarkomu daha çok diafiz yerleşimli küçük yuvarlak mavi hücreli tümör ve soğan zarı periost reaksiyonuyla ilişkilidir. Bu olguda “Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.” ve “Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Osteosarkom seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Osteoid osteom: Osteoid osteom küçük, ağrılı, NSAİİ’ye iyi yanıt veren benign nidus lezyonudur; malign osteoid paternine uymaz. Bu olguda “Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.” ve “Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Osteosarkom seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Kondrosarkom: Kondrosarkom erişkinlerde kıkırdak matriksi üreten tümördür; ergen metafiz osteoid üretimi tipik değildir. Bu olguda “Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.” ve “Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Osteosarkom seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Multipl miyelom: Vakadaki Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir ve Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır. Bu olguda “Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.” ve “Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Osteosarkom seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ergende diz çevresinde ağırlı kitle olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.” ve “Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.” birlikte okunduğunda Osteosarkom seçeneği öne çıkar; “Biyopside malign osteoid üretimi izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ergende diz çevresi metafiz yerleşimli agresif kemik lezyonu, güneş ışını periost reaksiyonu, Codman üçgeni ve malign hücrelerce osteoid üretimi osteosarkomu düşündürür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.”, “Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.” ve “Biyopside malign osteoid üretimi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Osteosarkom en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Lezyon ergen hastada distal femur metafizindedir.

Kanıt 2: Grafide güneş ışını periost reaksiyonu ve Codman üçgeni vardır.

Kanıt 3: Biyopside malign osteoid üretimi izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Osteosarkomda tanı koydurucu patolojik özellik malign hücrelerin osteoid üretmesidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 324: v194-new-324-antibiyotik-infüzyonu-sirasinda-kizarma

Başlık: Antibiyotik infüzyonu sırasında kızarma

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Vancomycin infüzyon reaksiyonunu histamin salınımı ve infüzyon hızıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, vancomycin infüzyonu başladıktan kısa süre sonra yüz-boyun kızarması ve kaşıntı gelişmesi nedeniyle izleniyor. Metisiline dirençli gram-pozitif enfeksiyon şüphesiyle vancomycin başlandığı, infüzyonun hızlı verildiği öğreniliyor. Nefes darlığı veya dil şişmesi tariflememektedir.

Demografi: 61 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 108/68 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,00 (yüksek)

Fizik Muayene

- Yüz, boyun ve üst gövdede yaygın eritem vardır.
- Hafif kaşıntı mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu reaksiyonda en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek
- B) Vancomycin dozunu hızla artırmak
- C) Protamin sülfat uygulamak
- D) Vitamin K vermek
- E) İnsülin infüzyonu başlamak

Doğru Cevap: Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek

A) Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek: Infüzyonu yavaşlatmak ve antihistaminik vermek vancomycin infüzyon reaksiyonunda uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.” ve “Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleşenir.

B) Vancomycin dozunu hızla artırmak: Vakadaki Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır ve Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir. Bu olguda “Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.” ve “Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Protamin sülfat uygulamak: Vakadaki Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır ve Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir. Bu olguda “Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.” ve “Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Vitamin K vermek: Vakadaki Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır ve Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir. Bu olguda “Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.” ve “Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) İnsülin infüzyonu başlamak: Vakadaki Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır ve Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir. Bu olguda “Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.” ve “Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antibiyotik infüzyonu sırasında kızarma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.” ve “Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.” birlikte okunduğunda Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek seçeneği öne çıkar; “Bulgular yüz-boyun ve üst gövdede eritem şeklindedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Vancomycin hızlı infüzyonla mast hücrelerinden histamin salınımına bağlı yüz-boyun kızarması ve kaşıntı oluşturabilir. Tedavi infüzyonu durdurmak veya yavaşlatmak, semptomlara göre antihistaminik vermek ve sonraki dozları daha yavaş uygulamaktır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.”, “Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.” ve “Bulgular yüz-boyun ve üst gövdede eritem şeklindedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Infüzyonu yavaşlatmak ve gerekirse antihistaminik vermek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kızarma ve kaşıntı vancomycin infüzyonu sırasında başlamıştır.

Kanıt 2: Infüzyonun hızlı verildiği öğrenilmiştir.

Kanıt 3: Bulgular yüz-boyun ve üst gövdede eritem şeklindedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Vancomycin infüzyon reaksiyonu hız bağımlı histamin salınımıyla ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 325: v194-new-325-antipsikotik-sonrasi-ates-ve-bogaz-agrisi

Başlık: Antipsikotik sonrası ateş ve boğaz ağrısı

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Clozapine tedavisinde agranülositoz riskini ateş ve nötropeniyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, clozapine tedavisi sırasında ateş ve boğaz ağrısı gelişmesi nedeniyle değerlendiriliyor. Tedaviye dirençli şizofreni nedeniyle iki ay önce clozapine başlandığı öğreniliyor. Son iki gündür ateş, halsizlik ve yutma ağrısı vardır.

Demografi: 32 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 112/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.5°C | Şok indeksi: 0,95 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Orofarenks hiperemiktir.
- Servikal hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Mutlak nötrofil sayısı

Etiket: Mutlak nötrofil sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Agranülositoz riskini gösterir. | Sonuç yorumu: Agranülositoz riskini gösterir. | Sonuç başlığı: Mutlak nötrofil sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Agranülositoz riskini gösterir. | Satırlar: Mutlak nötrofil sayısı / 420 /mm³ / >1500 /mm³ / Agranülositoz riskini gösterir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak
- B) Clozapine dozunu iki katına çıkarmak
- C) Clozapine dozunu azaltıp mutlak nötrofil sayısını 24 saat sonra yeniden değerlendirmek
- D) Varfarin başlamak
- E) Metotreksat vermek

Doğru Cevap: Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak

- A) Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak: Clozapine tedavisini kesmek ve nötropeni-enfeksiyon yönetimi başlatmak agranülositoz şüphesinde doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Hasta clozapine kullanmaktadır.” ve “Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Clozapine dozunu iki katına çıkarmak: Vakadaki Hasta clozapine kullanmaktadır ve Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir. Bu olguda “Hasta clozapine kullanmaktadır.” ve “Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Clozapine dozunu azaltıp mutlak nötrofil sayısını 24 saat sonra yeniden değerlendirmek: Vakadaki Hasta clozapine kullanmaktadır ve Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir. Bu olguda “Hasta clozapine kullanmaktadır.” ve “Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Varfarin başlamak: Vakadaki Hasta clozapine kullanmaktadır ve Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir. Bu olguda “Hasta clozapine kullanmaktadır.” ve “Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Metotreksat vermek: Vakadaki Hasta clozapine kullanmaktadır ve Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir. Bu olguda “Hasta clozapine kullanmaktadır.” ve “Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Antipsikotik sonrası ateş ve boğaz ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hasta clozapine kullanmaktadır.” ve “Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak seçeneği öne çıkar; “Mutlak nötrofil sayısı belirgin düşüktür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Clozapine agranülositoz yapabilen bir antipsikotiktir. Tedavi sırasında ateş, boğaz ağrısı ve ağır nötropeni gelişirse ilaç kesilmeli, enfeksiyon açısından değerlendirme ve nötropeni yönetimi yapılmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta clozapine kullanmaktadır.”, “Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.” ve “Mutlak nötrofil sayısı belirgin düşüktür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Clozapine tedavisini kesmek ve enfeksiyon-nötropeni yönetimi başlatmak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta clozapine kullanmaktadır.

Kanıt 2: Ateş ve boğaz ağrısı gelişmiştir.

Kanıt 3: Mutlak nötrofil sayısı belirgin düşüktür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Clozapine kullanan hastada ateş ve boğaz ağrısı agranülositoz açısından acil değerlendirilmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 326: v194-new-326-tekrarlayan-gut-ataklari

Başlık: Tekrarlayan gut atakları

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Allopurinolün ksantin oksidaz inhibisyonunu ürik asit üretimiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tekrarlayan gut atakları ve yüksek ürik asit düzeyi nedeniyle başvuruyor. Son bir yılda ayak başparmağı eklemine birkaç kez kızarıklık ve şiddetli ağrı atağı geçirdiği öğreniliyor. Akut atak geçtikten sonra ürat düşürücü tedavi planlanmaktadır.

Demografi: 54 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Muayenede akut artrit bulgusu gerilemiştir.
- Sağ birinci metatarsofalangeal eklemden hafif hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum ürik asit

Etiket: Serum ürik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hiperürisemiye destekler. | Sonuç yorumu: Hiperürisemiye destekler. | Sonuç başlığı: Serum ürik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hiperürisemiye destekler. | Satırlar: Serum ürik asit / 9.8 mg/dL / 3.5-7.2 mg/dL / Hiperürisemiye destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Allopurinolün ürik asit düzeyini azaltan temel mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ksantin oksidaz inhibisyonu
B) Siklooksijenaz irreversibl inhibisyonu
C) Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu
D) Beta-1 reseptör blokajı
E) H/K ATPaz inhibisyonu

Doğru Cevap: Ksantin oksidaz inhibisyonu

- A) Ksantin oksidaz inhibisyonu: Ksantin oksidaz inhibisyonu allopurinolün ürik asit üretimini azaltan temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.” ve “Serum ürik asit düzeyi yüksektir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Siklooksijenaz irreversibl inhibisyonu: Vakadaki Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır ve Serum ürik asit düzeyi yüksektir. Bu olguda “Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.” ve “Serum ürik asit düzeyi yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ksantin oksidaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu: Vakadaki Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır ve Serum ürik asit düzeyi yüksektir. Bu olguda “Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.” ve “Serum ürik asit düzeyi yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ksantin oksidaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Beta-1 reseptör blokajı: Beta-1 reseptör blokajı kardiyak hız ve kontraktiletiyi azaltır; ürik asit üretimini hedeflemez. Bu olguda “Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.” ve “Serum ürik asit düzeyi yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ksantin oksidaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) H/K ATPaz inhibisyonu: Vakadaki Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır ve Serum ürik asit düzeyi yüksektir. Bu olguda “Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.” ve “Serum ürik asit düzeyi yüksektir.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Ksantin oksidaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tekrarlayan gut atakları olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.” ve “Serum ürik asit düzeyi yüksektir.” birlikte okunduğunda Ksantin oksidaz inhibisyonu seçeneği öne çıkar; “Tedavi akut atak geçtikten sonra ürat düşürme amacıyla planlanmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Allopurinol ksantin oksidazı inhibe ederek hipoksantin ve ksantinden ürik asit oluşumunu azaltır. Kronik hiperürisemi kontrolünde kullanılır; akut gut atağının ani ağrı kontrolü için ilk ilaç değildir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.”, “Serum ürik asit düzeyi yüksektir.” ve “Tedavi akut atak geçtikten sonra ürat düşürme amacıyla planlanmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ksantin oksidaz inhibisyonu en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada tekrarlayan gut atağı öyküsü vardır.

Kanıt 2: Serum ürik asit düzeyi yüksektir.

Kanıt 3: Tedavi akut atak geçtikten sonra ürat düşürme amacıyla planlanmaktadır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Allopurinol ksantin oksidaz inhibitörüdür ve kronik ürat düşürücü tedavide kullanılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 327: v194-new-327-yutma-sonrasi-agiza-gida-gelmesi

Başlık: Yutma sonrası ağıza gıda gelmesi

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Zenker divertikülünde yutma güçlüğü, regürjitasyon ve aspirasyon riskini faringoözofageal poşla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yutma güçlüğü, ağız kokusu ve sindirilmemiş gıdaların ağıza geri gelmesi nedeniyle başvuruyor. Yaklaşık bir yıldır katı gıdaları yutarken takılma hissi yaşadığını, özellikle gece yatarken daha önce yediği gıdaların ağzına geldiğini belirtmektedir. Son aylarda öksürük atakları ve tekrarlayan aspirasyon şüphesi gelişmiştir.

Demografi: 71 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Boyun sol tarafında yutkunma sırasında hafif dolgunluk izlenir.
- Akciğer bazallerinde hafif raller duyulur.
- Ateş yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Baryumlu özofagus grafisi

Etiket: Baryumlu özofagus grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Hipofarenks posteriorunda kontrastla dolan sakküler poş izlendi. | Klinik anlam: Faringoözofageal divertikülü destekler. | Sonuç yorumu: Faringoözofageal divertikülü destekler. | Sonuç başlığı: Baryumlu özofagus grafisi | Sonuç özeti: Hipofarenks posteriorunda kontrastla dolan sakküler poş izlendi. | Yorum: Faringoözofageal divertikülü destekler. | Satırlar: Baryumlu özofagus grafisi / Hipofarenks posteriorunda kontrastla dolan sakküler poş izlendi. // Faringoözofageal divertikülü destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-168 | Başlık: Baryumlu özofagus grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Hipofarenks posteriorunda kontrastla dolan sakküler poş izlendi. | Klinik anlam: Faringoözofageal divertikülü destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/168_zenker_divertikulu_baryumlu_ozofagus_grafisi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/168_zenker_divertikulu_baryumlu_ozofagus_grafisi.webp | Alt text: Baryumlu özofagus grafisi - Hipofarenks posteriorunda kontrastla dolan sakküler poş izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Zenker divertikülü
B) Akut gastrit
C) Safra kesesi taşı
D) Mezenterik lenfadenit
E) Rektal prolapsus

Doğru Cevap: Zenker divertikülü

A) Zenker divertikülü: Zenker divertikülü hipofarenks posterior poşu, sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve aspirasyon bulgularıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.” ve “Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Akut gastrit: Akut gastrit epigastrik ağrı ve dispepsiyle seyreder; hipofarenks poşu ve gıda regürjitasyonunu açıklamaz. Bu olguda “Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.” ve “Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Zenker divertikülü seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Safra kesesi taşı: Safra kesesi taşı sağ üst kadranda ağrıya yapabilir; yutma sonrası sindirilmemiş gıda regürjitasyonu oluşturmaz. Bu olguda “Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.” ve “Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Zenker divertikülü seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Mezenterik lenfadenit: Mezenterik lenfadenit karın ağrısıyla ilişkilidir; hipofarengeal divertikül paternini açıklamaz. Bu olguda “Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.” ve “Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Zenker divertikülü seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Rektal prolapsus: Rektal prolapsus anorektal bölgeyle ilişkilidir; disfaji ve aspirasyon semptomlarını açıklamaz. Bu olguda “Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.” ve “Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.” ipuçları tanısal karar açısından Zenker divertikülü seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yutma sonrası ağıza gıda gelmesi olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.” ve “Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.” birlikte okunduğunda Zenker divertikülü seçeneği öne çıkar; “Baryumlu grafide hipofarenks posteriorunda sakküler poş izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı hastada yutma güçlüğü, ağız kokusu, sindirilmemiş gıda regürjitasyonu, aspirasyon atakları ve baryum grafisinde hipofarenks posterior poşu Zenker divertikülünü düşündürür. Lezyon Killian üçgeni bölgesinden gelişen pulsion divertikülüdür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.”, “Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.” ve “Baryumlu grafide hipofarenks posteriorunda sakküler poş izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Zenker divertikülü en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada sindirilmemiş gıda regürjitasyonu ve ağız kokusu vardır.

Kanıt 2: Tekrarlayan öksürük atakları aspirasyon riskini destekler.

Kanıt 3: Baryumlu grafide hipofarenks posteriorunda sakküler poş izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Zenker divertikülü yaşlı hastada disfaji, halitozis, regürjitasyon ve aspirasyonla akla gelir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 328: v194-new-328-agrisiz-sarilik-ve-kilo-kaybi

Başlık: Ağrısız sarılık ve kilo kaybı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Pankreas başı tümöründe ağrısız sarılık ve Courvoisier bulgusuyla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sarılık, koyu idrar ve kilo kaybı nedeniyle başvuruyor. Son iki ayda iştahsızlık ve kilo kaybı olduğunu, son haftalarda gözlerinde sararma ve dışkı renginde açılma fark ettiğini belirtmektedir. Şiddetli kolik ağrı tariflememektedir.

Demografi: 64 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Skleralar ikteriktir.
- Sağ üst kadranda ağrısız palpe edilebilen safra kesesi vardır.
- Kaşıntı izleri görülür.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Total bilirubin

Etiket: Total bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Obstrüktif sarılığı destekler. | Sonuç yorumu: Obstrüktif sarılığı destekler. | Sonuç başlığı: Total bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Obstrüktif sarılığı destekler. | Satırlar: Total bilirubin / 9.6 mg/dL / 0.2-1.2 mg/dL / Obstrüktif sarılığı destekler.

Tetkik 2: Abdominal BT

Etiket: Abdominal BT | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pankreas başında koledoku daraltan kitle izlendi. | Klinik anlam: Pankreas başı tümörü lehinedir. | Sonuç yorumu: Pankreas başı tümörü lehinedir. | Sonuç başlığı: Abdominal BT | Sonuç özeti: Pankreas başında koledoku daraltan kitle izlendi. | Yorum: Pankreas başı tümörü lehinedir. | Satırlar: Abdominal BT / Pankreas başında koledoku daraltan kitle izlendi. / / Pankreas başı tümörü lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-169 | Başlık: Abdominal BT | Modalite: ct | Bulgu: Pankreas başında koledoku daraltan kitle izlendi. | Klinik anlam: Pankreas başı tümörü lehinedir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/169_pankreas_basi_kitlesi_abdominal_bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/169_pankreas_basi_kitlesi_abdominal_bt.webp | Alt text: Abdominal BT - Pankreas başında koledoku daraltan kitle izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pankreas başı adenokarsinomu
B) Viral hepatit
C) Koledok taşı
D) Safra kesesi taşı kolığı
E) Fonksiyonel dispepsi

Doğru Cevap: Pankreas başı adenokarsinomu

- A) Pankreas başı adenokarsinomu: Pankreas başı adenokarsinomu ağrısız obstrüktif sarılık, kilo kaybı ve koledok basısı yapan kitleyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.” ve “Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Viral hepatit: Viral hepatit sarılık yapabilir ancak ağrısız palpe edilen safra kesesi ve pankreas başında koledoku daraltan kitle beklenmez. Bu olguda “Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.” ve “Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Pankreas başı adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Koledok taşı: Koledok taşı obstrüktif sarılık yapabilir ancak kilo kaybı ve pankreas başında kitle bulgusu malign obstrüksiyonu daha güçlü destekler. Bu olguda “Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.” ve “Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Pankreas başı adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Safra kesesi taşı kolığı: Safra kesesi taşı kolığı genellikle ağrılı ataklar yapar; ilerleyici ağrısız sarılık ve kilo kaybı daha çok malign obstrüksiyonu düşündürür. Bu olguda “Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.” ve “Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Pankreas başı adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Fonksiyonel dispepsi: Vakadaki Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır ve Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır. Bu olguda “Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.” ve “Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Pankreas başı adenokarsinomu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ağrısız sarılık ve kilo kaybı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.” ve “Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Pankreas başı adenokarsinomu seçeneği öne çıkar; “BT’de pankreas başında koledoku daraltan kitle izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağrısız ilerleyici sarılık, kilo kaybı, kaşıntı, açık renk dışkı ve ağrısız büyümüş safra kesesi pankreas başı adenokarsinomunu düşündürür. Koledok basısı obstrüktif sarılığa yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.”, “Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.” ve “BT’de pankreas başında koledoku daraltan kitle izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pankreas başı adenokarsinomu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada ağrısız ilerleyici sarılık ve kilo kaybı vardır.

Kanıt 2: Ağrısız palpe edilebilen safra kesesi saptanmıştır.

Kanıt 3: BT’de pankreas başında koledoku daraltan kitle izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Ağrısız sarılık ve Courvoisier bulgusu pankreas başı tümörü açısından uyarıcıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 329: v194-new-329-siklik-pelvik-agri-ve-infertilite

Başlık: Siklik pelvik ağrı ve infertilite

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Endometrioziste siklik pelvik ağrı, disparoni ve infertiliteyle tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, adet döneminde artan pelvik ağrı ve çocuk sahibi olamama nedeniyle başvuruyor. Son iki yıldır giderek artan dismenore, derin disparoni ve adet öncesi başlayan pelvik ağrı tariflemektedir. Bir yıldır korunmasız ilişkiye rağmen gebelik oluşmamıştır.

Demografi: 32 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Pelvik muayenede uterus hareketleri ağırlıdır.
- Posterior fornikte hassasiyet vardır.
- Ateş yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol overde homojen düşük ekolu kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Endometrioma olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Endometrioma olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sol overde homojen düşük ekolu kistik lezyon izlendi. | Yorum: Endometrioma olasılığını destekler. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / Sol overde homojen düşük ekolu kistik lezyon izlendi. // Endometrioma olasılığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-170 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sol overde homojen düşük ekolu kistik lezyon izlendi. | Klinik anlam: Endometrioma olasılığını destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/170_endometrioma_transvajinal_ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsds.public.blob.vercel-storage.com/170_endometrioma_transvajinal_ultrasonografi.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Sol overde homojen düşük ekolu kistik lezyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endometriozis
B) Servikal polip
C) Alt uterin segment plasenta yerleşimi
D) Over hiperstimülasyon sendromu
E) Vajinal kandidiyazis

Doğru Cevap: Endometriozis

- A) Endometriozis: Endometriozis siklik pelvik ağrı, derin disparoni, infertilite ve endometrioma bulgusuyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.” ve “Derin disparoni ve infertilite vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Servikal polip: Servikal polip genellikle ara kanama veya temas kanaması yapar; siklik derin pelvik ağrı ve infertiliteyi açıklamaz. Bu olguda “Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.” ve “Derin disparoni ve infertilite vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometriozis seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Alt uterin segment plasenta yerleşimi: Alt uterin segment plasenta yerleşimi gebelikte ağrısız üçüncü trimester kanamasıyla seyreder; bu hasta infertiliteyle başvurmaktadır. Bu olguda “Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.” ve “Derin disparoni ve infertilite vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometriozis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Over hiperstimülasyon sendromu: Over hiperstimülasyon sendromu ovulasyon indüksiyonu sonrası asit ve büyük overlerle seyreder; bu öykü yoktur. Bu olguda “Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.” ve “Derin disparoni ve infertilite vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometriozis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Vajinal kandidiyazis: Vajinal kandidiyazis kaşıntı ve beyaz akıntıyla ilişkilidir; endometrioma ve siklik ağrı yapmaz. Bu olguda “Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.” ve “Derin disparoni ve infertilite vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Endometriozis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Siklik pelvik ağrı ve infertilite olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.” ve “Derin disparoni ve infertilite vardır.” birlikte okunduğunda Endometriozis seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide endometrioma ile uyumlu over kisti izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Siklik pelvik ağrı, ilerleyici dismenore, derin disparoni, infertilite ve endometrioma görünümü endometriozisi düşündürür. Ektopik endometrial doku hormonlara yanıt vererek inflamasyon, adezyon ve ağrı oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.”, “Derin disparoni ve infertilite vardır.” ve “Ultrasonografide endometrioma ile uyumlu over kisti izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Endometriozis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Pelvik ağrı adet döngüsüyle ilişkili ve giderek artmaktadır.

Kanıt 2: Derin disparoni ve infertilite vardır.

Kanıt 3: Ultrasonografide endometrioma ile uyumlu over kisti izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Endometriozis siklik pelvik ağrı, disparoni ve infertiliteyle klasik olarak ilişkilidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 330: v194-new-330-ikinci-trimesterde-agrısız-servikal-acılma

Başlık: İkinci trimesterde ağrısız servikal açılma

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Servikal yetmezlikte ağrısız ikinci trimester servikal dilatasyon ve serklaj yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, rutin kontrolde servikal kısılma ve açılma saptanması nedeniyle değerlendirmeye alınıyor. Daha önce ikinci trimesterde ağrısız gebelik kaybı öyküsü vardır. Bu gebelikte düzenli kasılma, kanama veya ateş tariflememektedir.

Demografi: 29 yaşında gebe hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Uterus hassas değildir.
- Spekulum muayenesinde membranlar intakt görünür.
- Düzenli uterin kontraksiyon saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Transvajinal servikal uzunluk ölçümü

Etiket: Transvajinal servikal uzunluk ölçümü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Serviks belirgin kısa saptandı. | Klinik anlam: Servikal yetmezlik açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Servikal yetmezlik açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Transvajinal servikal uzunluk ölçümü | Sonuç özeti: Serviks belirgin kısa saptandı. | Yorum: Servikal yetmezlik açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Transvajinal servikal uzunluk ölçümü / 18 mm // Servikal yetmezlik açısından uyarıcıdır.

Tetkik 2: Pelvik ultrasonografi

Etiket: Pelvik ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: İntrauterin canlı gebelik ve membranların intakt olduğu izlendi. | Klinik anlam: Aktif doğum veya membran rüptürü bulgusu yoktur. | Sonuç yorumu: Aktif doğum veya membran rüptürü bulgusu yoktur. | Sonuç başlığı: Pelvik ultrasonografi | Sonuç özeti: İntrauterin canlı gebelik ve membranların intakt olduğu izlendi. | Yorum: Aktif doğum veya membran rüptürü bulgusu yoktur. | Satırlar: Pelvik ultrasonografi / İntrauterin canlı gebelik ve membranların intakt olduğu izlendi. // Aktif doğum veya membran rüptürü bulgusu yoktur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-171 | Başlık: Pelvik ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: İntrauterin canlı gebelik ve membranların intakt olduğu izlendi. | Klinik anlam: Aktif doğum veya membran rüptürü bulgusu yoktur. | URL: https://iukbtlkzixctqsd.public.blob.vercel-storage.com/171_intrauterin_canli_gebelik_membran_intakt_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqsd.public.blob.vercel-storage.com/171_intrauterin_canli_gebelik_membran_intakt_usg.webp | Alt text: Pelvik ultrasonografi - İntrauterin canlı gebelik ve membranların intakt olduğu izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Servikal serklaj değerlendirilmesi
- B) Metotreksat başlanması
- C) Acil histerektomi
- D) Dijital muayenelerin sık tekrarlanması
- E) Uterin masaj yapılması

Doğru Cevap: Servikal serklaj değerlendirilmesi

- A) Servikal serklaj değerlendirilmesi: Servikal serklaj değerlendirilmesi servikal yetmezlik düşündüren ağrısız kısılma ve kayıp öyküsünde uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.” ve “Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Metotreksat başlanması: Metotreksat ektopik gebelik tedavisinde kullanılır; canlı intrauterin gebelikte servikal yetmezliği tedavi etmez. Bu olguda “Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.” ve “Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Servikal serklaj değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Acil histerektomi: Vakadaki Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır ve Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır. Bu olguda “Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.” ve “Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Servikal serklaj değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Dijital muayenelerin sık tekrarlanması: Sık dijital muayene enfeksiyon ve membran etkilenimi riskini artırabilir; tedavi yaklaşımı değildir. Bu olguda “Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.” ve “Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Servikal serklaj değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Uterin masaj yapılması: Vakadaki Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır ve Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır. Bu olguda “Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.” ve “Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Servikal serklaj değerlendirilmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: İkinci trimesterde ağrısız servikal açılma olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.” ve “Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.” birlikte okunduğunda Servikal serklaj değerlendirilmesi seçeneği öne çıkar; “Kasılma, enfeksiyon veya membran rüptürü bulgusu yoktur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağrısız ikinci trimester servikal kısılma/açılma, önceki ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü ve kontraksiyon olmaması servikal yetmezliği düşündürür. Uygun seçilmiş hastada serklaj gebeliğin devamına yardımcı olabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.”, “Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.” ve “Kasılma, enfeksiyon veya membran rüptürü bulgusu yoktur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Servikal serklaj değerlendirilmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastanın önceki gebeliğinde ağrısız ikinci trimester kayıp öyküsü vardır.

Kanıt 2: Bu gebelikte serviks belirgin kısıdır.

Kanıt 3: Kasılma, enfeksiyon veya membran rüptürü bulgusu yoktur.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Servikal yetmezlikte ağrısız dilatasyon ve ikinci trimester kayıp öyküsü serklaj endikasyonu açısından önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 331:

v194-new-331-membran-rupturu-sonrasi-fetal-kalp-atiminda-dusme

Başlık: Membran rüptürü sonrası fetal kalp atımında düşme

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Vasa previa'da membran rüptürü sonrası ağrısız kanama ve fetal bradikardiyi tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, spontan membran rüptürünü takiben gelişen vajinal kanama sırasında fetal kalp atımında ani düşme olması nedeniyle izleniyor. Gebeliğinde velamentöz kordon insersiyonu şüphesi nedeniyle yakın takip önerildiği öğreniliyor. Membran rüptüründen hemen sonra parlak kırmızı kanama başlamış, anne karın ağrısı tariflememiştir.

Demografi: 30 yaşında gebe hasta | Setting: Doğumhane

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Anne hemodinamik olarak stabildir.
- Uterus yumuşak ve hassasiyetsizdir.
- Vajinal kanama az-orta miktardadır.
- Fetal monitörizasyonda kalıcı bradikardi izlenmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fetal kalp hızı izlemi

Etiket: Fetal kalp hızı izlemi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Membran rüptürü sonrası kalıcı bradikardi saptandı. | Klinik anlam: Akut fetal kan kaybı açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Akut fetal kan kaybı açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Fetal kalp hızı izlemi | Sonuç özeti: Membran rüptürü sonrası kalıcı bradikardi saptandı. | Yorum: Akut fetal kan kaybı açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Fetal kalp hızı izlemi / 80 /dk / 110-160 /dk / Akut fetal kan kaybı açısından uyarıcıdır.

Tetkik 2: Renkli Doppler ultrasonografi

Etiket: Renkli Doppler ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Servikal internal os üzerinde fetal damar seyri izlendi. | Klinik anlam: Vasa previa lehinedir. | Sonuç yorumu: Vasa previa lehinedir. | Sonuç başlığı: Renkli Doppler ultrasonografi | Sonuç özeti: Servikal internal os üzerinde fetal damar seyri izlendi. | Yorum: Vasa previa lehinedir. | Satırlar: Renkli Doppler ultrasonografi / Servikal internal os üzerinde fetal damar seyri izlendi. / / Vasa previa lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-172 | Başlık: Renkli Doppler ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Servikal internal os üzerinde fetal damar seyri izlendi. | Klinik anlam: Vasa previa lehinedir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/172_vasa_previa_renkli_doppler_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/172_vasa_previa_renkli_doppler_usg.webp | Alt text: Renkli Doppler ultrasonografi - Servikal internal os üzerinde fetal damar seyri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Vasa previa
B) Uterin rüptür
C) Servikal polip
D) Erken membran rüptürüyle ilişkili basit sıvı geliş
E) Endometrit

Doğru Cevap: Vasa previa

- A) Vasa previa: Vasa previa membran rüptürü sonrası fetal damar yırtılması, ağrısız kanama ve fetal bradikardiye en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.” ve “Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.
- B) Uterin rüptür: Uterin rüptürde genellikle şiddetli karın ağrısı, uterin hassasiyet ve maternal instabilite beklenebilir; burada fetal damar seyri gösterilmiştir. Bu olguda “Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.” ve “Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Vasa previa seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Servikal polip: Servikal polip hafif temas kanaması yapabilir ancak membran rüptürü sonrası kalıcı fetal bradikardiyi açıklamaz. Bu olguda “Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.” ve “Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Vasa previa seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Erken membran rüptürüyle ilişkili basit sıvı geliş: Basit sıvı geliş fetal bradikardi ve parlak kanamayla seyreden akut fetal kan kaybını açıklamaz. Bu olguda “Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.” ve “Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Vasa previa seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Endometrit: Endometrit postpartum ateş ve uterin hassasiyetle ilişkilidir; bu intrapartum ani fetal bradikardi tablosu değildir. Bu olguda “Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.” ve “Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Vasa previa seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Membran rüptürü sonrası fetal kalp atımında düşme olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.” ve “Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Vasa previa seçeneği öne çıkar; “Doppler ultrasonografide internal os üzerinde fetal damar seyri gösterilmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Membran rüptürü sonrası ağrısız parlak kanama ile birlikte fetal bradikardi gelişmesi vasa previa'yı düşündürür. Korunmasız fetal damarların yırtılması fetal kan kaybına yol açtığı için acil doğum planlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.”, “Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.” ve “Doppler ultrasonografide internal os üzerinde fetal damar seyri gösterilmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Vasa previa en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kanama membran rüptüründen hemen sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Anne hemodinamik olarak stabilken fetüste kalıcı bradikardi gelişmiştir.

Kanıt 3: Doppler ultrasonografide internal os üzerinde fetal damar seyri gösterilmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Vasa previa'da kanama maternal değil fetal kaynaklıdır; fetal bradikardi belirgin uyarıcıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 332: v194-new-332-gun-icinde-artan-cift-gorme

Başlık: Gün içinde artan çift görme

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Myastenia graviste dalgalanan kas güçsüzlüğü ve asetilkolin reseptör antikoruyla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, gün içinde artan göz kapağı düşüklüğü, çift görme ve çığneme yorgunluğu nedeniyle başvuruyor. Yakınmalarının sabah daha hafif olduğunu, gün içinde konuşma ve çığneme ile arttığını belirtmektedir. Duyu kaybı veya bilinç değişikliği yoktur.

Demografi: 35 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bilateral pitoz vardır ve yukarı bakışla belirginleşir.
- Ekstraoküler hareketlerde yorgunlukla kısıtlılık gelişir.
- Derin tendon refleksleri normaldir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Asetilkolin reseptör antikor

Etiket: Asetilkolin reseptör antikor | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Myastenia gravis tanısını destekler. | Sonuç yorumu: Myastenia gravis tanısını destekler. | Sonuç başlığı: Asetilkolin reseptör antikor | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Myastenia gravis tanısını destekler. | Satırlar: Asetilkolin reseptör antikor / Pozitif saptandı. // Myastenia gravis tanısını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Myastenia gravis
B) Lambert-Eaton myastenik sendromu
C) Parkinson hastalığı
D) Amyotrofik lateral skleroz
E) Okülomotor sinir paralizisi

Doğru Cevap: Myastenia gravis

- A) Myastenia gravis: Myastenia gravis dalgalanan oküler-bulber güçsüzlük ve asetilkolin reseptör antikor pozitifliğiyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.” ve “Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Lambert-Eaton myastenik sendromu: Lambert-Eaton myastenik sendromunda güçsüzlük egzersizle kısmen düzelebilir ve otonom bulgular daha belirgindir; bu hastada oküler dalgalanma ve asetilkolin reseptör antikoruna öne çıkmaktadır. Bu olguda “Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.” ve “Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.” ipuçları tanısal karar açısından Myastenia gravis seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Parkinson hastalığı: Parkinson hastalığında bradikinezi, rijidite ve istirahat tremoru ön plandadır; dalgalanan pitoz tipik değildir. Bu olguda “Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.” ve “Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.” ipuçları tanısal karar açısından Myastenia gravis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Amyotrofik lateral skleroz: Amyotrofik lateral skleroz üst ve alt motor nöron bulgularıyla seyreder; oküler kaslar genellikle korunur. Bu olguda “Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.” ve “Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.” ipuçları tanısal karar açısından Myastenia gravis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Okülomotor sinir paralizisi: Okülomotor sinir paralizisi daha sabit bir kraniyal sinir defisiti oluşturur; kullanım ile artan yaygın nöromusküler kavşak güçsüzlüğünü açıklamaz. Bu olguda “Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.” ve “Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.” ipuçları tanısal karar açısından Myastenia gravis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Gün içinde artan çift görme olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.” ve “Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.” birlikte okunduğunda Myastenia gravis seçeneği öne çıkar; “Asetilkolin reseptör antikor pozitif saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Dalgalanan, kullanım ile artan oküler ve bulber kas güçsüzlüğü, normal refleksler ve asetilkolin reseptör antikor pozitifliği myastenia gravis düşündürür. Temel bozukluk nöromusküler kavşakta postsinaptik asetilkolin reseptörlerine karşı otoantikorlardır. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.”, “Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.” ve “Asetilkolin reseptör antikor pozitif saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Myastenia gravis en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Pitoz ve diplopi gün içinde ve kullanım ile artmaktadır.

Kanıt 2: Duyu kaybı yoktur ve refleksler korunmuştur.

Kanıt 3: Asetilkolin reseptör antikor pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Myastenia graviste güçsüzlük kullanım ile artar, dinlenmeyle azalır ve refleksler genellikle korunur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 333: v194-new-333-alinda-vezikuler-dokuntu-ve-goz-agrisi

Başlık: Alında veziküler döküntü ve göz ağrısı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Herpes zoster oftalmikusta Hutchinson bulgusunu oküler tutulum riskiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ alın ve burun ucunda ağrılı veziküler döküntü ile göz ağrısı nedeniyle başvuruyor. Döküntünün tek taraflı başladığı, yanma tarzında ağrı ve gözde kızarıklık eşlik ettiği öğreniliyor. Daha önce suçiçeği geçirmişti.

Demografi: 67 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ trigeminal oftalmik dal dermatomunda veziküller vardır.
- Burun ucunda veziküler lezyon izlenir.
- Sağ göz konjonktivası hiperemiktir ve fotofobi vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi
B) Topikal antiviral damla ile sistemik tedaviyi göz değerlendirmesi sonrasına bırakmak
C) Alerji testi sonucu izlem planlamak
D) Oral antibiyotikle tek başına tedavi
E) Göz muayenesi olmadan ayaktan izlem

Doğru Cevap: Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi

A) Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi: Sistemik antiviral tedavi ve acil göz değerlendirmesi herpes zoster oftalmikus ve oküler risk varlığında doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.” ve “Burun ucunda veziküler lezyon vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Topikal antiviral damla ile sistemik tedaviyi göz değerlendirmesi sonrasına bırakmak: Vakadaki Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır ve Burun ucunda veziküler lezyon vardır. Bu olguda “Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.” ve “Burun ucunda veziküler lezyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Alerji testi sonucu izlem planlamak: Vakadaki Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır ve Burun ucunda veziküler lezyon vardır. Bu olguda “Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.” ve “Burun ucunda veziküler lezyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral antibiyotikle tek başına tedavi: Vakadaki Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır ve Burun ucunda veziküler lezyon vardır. Bu olguda “Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.” ve “Burun ucunda veziküler lezyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Göz muayenesi olmadan ayaktan izlem: Vakadaki Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır ve Burun ucunda veziküler lezyon vardır. Bu olguda “Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.” ve “Burun ucunda veziküler lezyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Alında veziküler döküntü ve göz ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.” ve “Burun ucunda veziküler lezyon vardır.” birlikte okunduğunda Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi seçeneği öne çıkar; “Gözde hiperemi ve fotofobi eşlik etmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Trigeminal oftalmik dal dermatomunda ağrılı veziküller ve burun ucunda lezyon herpes zoster oftalmikus için uyarıcıdır. Burun ucu tutulumu nazosiller dal etkilenimini ve oküler komplikasyon riskini artırır; sistemik antiviral ve göz değerlendirmesi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.”, “Burun ucunda veziküler lezyon vardır.” ve “Gözde hiperemi ve fotofobi eşlik etmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Sistemik antiviral tedavi ve acil göz hastalıkları değerlendirmesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Döküntü trigeminal oftalmik dal dermatomunda tek taraflıdır.

Kanıt 2: Burun ucunda veziküler lezyon vardır.

Kanıt 3: Gözde hiperemi ve fotofobi eşlik etmektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Hutchinson bulgusu herpes zoster oftalmikusta oküler tutulum riski açısından önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 334: v194-new-334-uyumadan-enerjik-olma-ve-taskinlik

Başlık: Uyumadan enerjik olma ve taşkınlik

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Bipolar mani atağını taşkın duygudurum, uyku ihtiyacı azalması ve riskli davranışla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ailesi tarafından günlerdir uyumaması, aşırı konuşması ve riskli harcamalar yapması nedeniyle getiriliyor. Son bir haftadır günde 2 saat uyumasına rağmen yorulmadığı, yeni büyük projeler başlattığı ve kontrolsüz para harcadığı öğreniliyor. Madde kullanımı tarifi lenmemektedir.

Demografi: 26 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Hasta taşkın duygudurumlu, basınçlı konuşmalı ve dikkat dağınıktır.
- Grandiyöz düşünceler ifade eder.
- Psikomotor aktivitesi artmıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Toksikoloji taraması

Etiket: Toksikoloji taraması | Tip: lab | ALT tip: Laboratuvar | Özet: Uyarıcı madde açısından negatif saptandı. | Klinik anlam: Madde kaynaklı tabloyu geri plana iter. | Sonuç yorumu: Madde kaynaklı tabloyu geri plana iter. | Sonuç başlığı: Toksikoloji taraması | Sonuç özeti: Uyarıcı madde açısından negatif saptandı. | Yorum: Madde kaynaklı tabloyu geri plana iter. | Satırlar: Toksikoloji taraması / Uyarıcı madde açısından negatif saptandı. // Madde kaynaklı tabloyu geri plana iter.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mani atağı
B) Panik bozukluk
C) Major depresif epizod
D) Somatizasyon bozukluğu
E) Deliryum

Doğru Cevap: Mani atağı

- A) Mani atağı: Mani atağı uyku ihtiyacında azalma, taşkın duygudurum, grandiyözite ve riskli davranışlarla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.” ve “Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Panik bozukluk: Panik bozukluk kısa süreli yoğun anksiyete ataklarıyla seyreder; günler süren taşkınlik ve grandiyözite beklenmez. Bu olguda “Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.” ve “Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mani atağı seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Major depresif epizod: Major depresif epizod çökkün duygudurum ve enerji azalmasıyla ilişkilidir; bu hasta taşkın ve aşırı aktiftir. Bu olguda “Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.” ve “Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mani atağı seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Somatizasyon bozukluğu: Somatizasyon bozukluğunda bedensel yakınmalar ön plandadır; manik davranış paternini açıklayamaz. Bu olguda “Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.” ve “Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mani atağı seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Deliryum: Deliryum dalgalanan bilinç ve dikkat bozukluğuyla seyreder; bu hastada yönelim bozukluğu değil manik belirtiler baskındır. Bu olguda “Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.” ve “Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Mani atağı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uyumadan enerjik olma ve taşkınlik olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.” ve “Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.” birlikte okunduğunda Mani atağı seçeneği öne çıkar; “Riskli harcama ve artmış psikomotor aktivite izlenmektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uyku ihtiyacında azalma, taşkın duygudurum, basınçlı konuşma, grandiyözite, artmış aktivite ve riskli davranışlar mani atağını düşündürür. Semptomların günlerce sürmesi ve işlevselliği bozması tanıyı destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.”, “Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.” ve “Riskli harcama ve artmış psikomotor aktivite izlenmektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Mani atağı en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hasta günlerdir çok az uyumasına rağmen enerjik kalmaktadır.

Kanıt 2: Basınçlı konuşma ve grandiyöz düşünceler vardır.

Kanıt 3: Riskli harcama ve artmış psikomotor aktivite izlenmektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Manide uyku ihtiyacı azalır; hasta az uyusa da yorgun hissetmeyebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: anatomy

VAKA 335: v195-new-335-sinus-enfeksiyonu-sonrasi-cift-gorme

Başlık: Sinüs enfeksiyonu sonrası çift görme

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Cavernous sinus içinde nervus abducens tutulumunu lateral rektus paralizisiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yüz ağrısı ve ateşi takiben başlayan çift görme nedeniyle başvuruyor. Son bir haftadır yüz orta hattında ağrı ve burun çevresinde enfeksiyon bulguları olduğu, son iki gündür sağa bakarken çift görmesinin belirginleştiği öğreniliyor. Travma öyküsü yoktur.

Demografi: 39 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 38.4°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır.
- Sağ periorbital ödem ve hafif proptoz vardır.
- Kornea refleksi korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntüleme

Etiket: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntüleme | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sağ kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler izlendi. | Klinik anlam: Kavernöz sinüs tutulumunu destekler. | Sonuç yorumu: Kavernöz sinüs tutulumunu destekler. | Sonuç başlığı: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntüleme | Sonuç özeti: Sağ kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler izlendi. | Yorum: Kavernöz sinüs tutulumunu destekler. | Satırlar: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntüleme / Sağ kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler izlendi. // Kavernöz sinüs tutulumunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-173 | Başlık: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntüleme | Modalite: mri | Bulgu: Sağ kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler izlendi. | Klinik anlam: Kavernöz sinüs tutulumunu destekler. | URL: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/173_kavernoze_sinus_trombozu_kraniyal_mr.webp | Thumbnail: https://iukbtikzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/173_kavernoze_sinus_trombozu_kraniyal_mr.webp | Alt text: Kontrastlı kraniyal manyetik rezonans görüntüleme - Sağ kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastadaki göz hareket kusurunu en iyi açıklayan sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Abducens siniri
B) Troklear sinir
C) Okulomotor sinir
D) Optik sinir
E) Nervus olfactorius

Doğru Cevap: Abducens siniri

A) Abducens siniri: Abducens siniri lateral rektus kasını innerve ettiği için abduksiyon kaybı ve horizontal diplopiyi açıklar. Vakadaki "Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır." ve "Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Troklear sinir: Troklear sinir superior oblik kasını innerve eder ve özellikle aşağı-ıçe bakış bozukluğuyla ilişkilidir. Bu olguda "Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır." ve "Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abducens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Okulomotor sinir: Okulomotor sinir çoğu ekstraoküler kası ve pupilla parasempatik liflerini taşır; izole abduksiyon kaybını en iyi açıklamaz. Bu olguda "Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır." ve "Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abducens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Optik sinir: Vakadaki Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır ve Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır. Bu olguda "Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır." ve "Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abducens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Nervus olfactorius: Vakadaki Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır ve Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır. Bu olguda "Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır." ve "Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır." ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Abducens siniri seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sinüs enfeksiyonu sonrası çift görme olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. "Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır." ve "Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır." birlikte okunduğunda Abducens siniri seçeneği öne çıkar; "Çift görme özellikle sağa bakış sırasında belirginleşmektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Abducens siniri lateral rektus kasını innerve eder ve gözün abduksiyonunu sağlar. Kavernöz sinüs içinde serbest seyretmesi nedeniyle enfeksiyöz veya trombotik süreçlerde erken etkilenebilir; abduksiyon kaybı ve horizontal diplopi gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır.", "Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır." ve "Çift görme özellikle sağa bakış sırasında belirginleşmektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Abducens siniri en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada kavernöz sinüs komşuluğunda inflamatuvar trombotik değişiklikler vardır.

Kanıt 2: Sağ göz abduksiyonu belirgin kısıtlıdır.

Kanıt 3: Çift görme özellikle sağa bakış sırasında belirginleşmektedir.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olgusuyla uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Kavernöz sinüs patolojilerinde nervus abducens sık etkilendir ve lateral rektus paralizisi yapar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 336: v195-new-336-boyun-kaburgasi-ve-elde-guacsuzluk

Başlık: Boyun kaburgası ve elde güçsüzlük

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Alt brakiyal plexus trunkus tutulumunu elde intrinsik kas zayıflığı ve medial ön kol duyusuyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ elde güçsüzlük ve ön kol iç yüzünde uyuşma nedeniyle başvuruyor. Yakınmalarının kolunu yukarı kaldırdığında arttığını, uzun süredir sağ omuz-boyun bölgesinde baskı hissi olduğunu belirtmektedir. Travma öyküsü yoktur.

Demografi: 28 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ elde intrinsik kaslarda hafif atrofi ve kavrama gücünde azalma vardır.
- Ön kol medial yüzünde duyu azalması saptanır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Servikal grafi

Etiket: Servikal grafi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ tarafta servikal kaburga ile uyumlu kemik yapı izlendi. | Klinik anlam: Torasik çıkış basısı için anatomik zemin oluşturur. | Sonuç yorumu: Torasik çıkış basısı için anatomik zemin oluşturur. | Sonuç başlığı: Servikal grafi | Sonuç özeti: Sağ tarafta servikal kaburga ile uyumlu kemik yapı izlendi. | Yorum: Torasik çıkış basısı için anatomik zemin oluşturur. | Satırlar: Servikal grafi / Sağ tarafta servikal kaburga ile uyumlu kemik yapı izlendi. // Torasik çıkış basısı için anatomik zemin oluşturur.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-174 | Başlık: Servikal grafi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ tarafta servikal kaburga ile uyumlu kemik yapı izlendi. | Klinik anlam: Torasik çıkış basısı için anatomik zemin oluşturur. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/174_servikal_kaburga_servikal_grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/174_servikal_kaburga_servikal_grafi.webp | Alt text: Servikal grafi - Sağ tarafta servikal kaburga ile uyumlu kemik yapı izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tabloda en çok etkilenen brakiyal plexus bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alt trunkus
- B) Üst trunkus
- C) Posterior kord
- D) Lateral kord
- E) Nervus phrenicus

Doğru Cevap: Alt trunkus

- A) Alt trunkus: Alt trunkus C8-T1 liflerini içerdiği için elde intrinsik kas zayıflığı ve medial ön kol duyu kaybını açıklar. Vakadaki “Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.” ve “Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Üst trunkus: Üst trunkus C5-C6 lifleriyle omuz abduksiyonu ve dirsek fleksiyonu kaybı yapar; medial ön kol duyusunu açıklamaz. Bu olguda “Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.” ve “Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Alt trunkus seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Posterior kord: Posterior kord radial ve axillar sinir lifleriyle ilişkilidir; servikal kaburga kaynaklı klasik alt trunkus paternini en iyi açıklamaz. Bu olguda “Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.” ve “Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Alt trunkus seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Lateral kord: Lateral kord daha çok musclocutaneus ve median sinirin lateral köküne katkı verir; medial ön kol duyusunun ana kaynağı değildir. Bu olguda “Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.” ve “Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Alt trunkus seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Nervus phrenicus: Vakadaki Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır ve Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır. Bu olguda “Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.” ve “Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Alt trunkus seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Boyun kaburgası ve elde güçsüzlük olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.” ve “Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.” birlikte okunduğunda Alt trunkus seçeneği öne çıkar; “Ön kol medial yüzünde duyu azalması izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Servikal kaburga torasik çıkışta özellikle C8-T1 liflerini içeren alt trunkusu basıya uğratabilir. Elde intrinsik kas zayıflığı ve medial ön kol-elde duyu azalması alt trunkus etkilenimini destekler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.”, “Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.” ve “Ön kol medial yüzünde duyu azalması izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Alt trunkus en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Servikal grafide servikal kaburga saptanmıştır.

Kanıt 2: Elde intrinsik kas zayıflığı ve atrofi vardır.

Kanıt 3: Ön kol medial yüzünde duyu azalması izlenmiştir.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguya uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Servikal kaburga torasik çıkışta C8-T1 alt trunkus basısı yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 337:

v195-new-337-pelvik-lenf-nodu-diseksiyonu-sonrasi-bacak-gucsuzlugu

Başlık: Pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası bacak güçsüzlüğü

Branş: anatomy | İlgili Branş: Anatomi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Anatomik yapıyı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Pelvik cerrahi sonrası nervus obturatorius hasarını uyluk adduksiyon kaybıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ameliyat sonrasında bacaklarını birbirine yaklaştırmakta zorlanma ve uyluk iç yüzünde uyuşma nedeniyle başvuruyor. Pelvik lenf nodu diseksiyonu yapılan operasyon sonrası yakınmaların başladığı öğreniliyor. Yürümede bacaklarını kapatırken zorlandığını belirtmektedir.

Demografi: 60 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ uyluk adduksiyonu zayıftır.
- Sağ uyluk medial yüzünde duyu azalması vardır.
- Diz ekstansiyonu ve kalça fleksiyonu korunmuştur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada hasarlanması en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nervus obturatorius
- B) Nervus femoralis
- C) Nervus ischiadicus
- D) Nervus gluteus inferior
- E) Nervus cutaneus femoris lateralis

Doğru Cevap: Nervus obturatorius

A) Nervus obturatorius: Nervus obturatorius uyluk adduktorlarını ve medial uyluk duyusunu etkilediği için bu postoperatif tabloyu açıklar. Vakadaki “Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Nervus femoralis: Nervus femoralis diz ekstansiyonu ve anterior uyluk duyusuyla ilişkilidir; bu hastada diz ekstansiyonu korunmuştur. Bu olguda “Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus obturatorius seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nervus ischiadicus: Nervus ischiadicus arka uyluk, bacak ve ayak motor-duyu fonksiyonlarıyla ilişkilidir; izole adduksiyon kaybını açıklamaz. Bu olguda “Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus obturatorius seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Nervus gluteus inferior: Nervus gluteus inferior kalça ekstansiyonunu sağlayan gluteus maximus kasını innerve eder; uyluk adduksiyonunu sağlamaz. Bu olguda “Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus obturatorius seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Nervus cutaneus femoris lateralis: Vakadaki Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır ve Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır. Bu olguda “Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Nervus obturatorius seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası bacak güçsüzlüğü olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur.

“Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.” ve “Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.” birlikte okunduğunda Nervus obturatorius seçeneği öne çıkar; “Uyluk medial yüzünde duyu azalması vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Nervus obturatorius pelvis yan duvarında seyreder, obturator kanaldan geçer ve uyluk adduktor kaslarını innerve eder. Pelvik lenf nodu diseksiyonunda yaralanırsa uyluk adduksiyonu zayıflar ve medial uyluk duyusu azalır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.”, “Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.” ve “Uyluk medial yüzünde duyu azalması vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nervus obturatorius en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Yakınmalar pelvik lenf nodu diseksiyonu sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Uyluk adduksiyonu zayıflamıştır.

Kanıt 3: Uyluk medial yüzünde duyu azalması vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Nervus obturatorius uyluk adduksiyonunun ana motor siniridir ve pelvik cerrahide risk altındadır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: physiology

VAKA 338: v195-new-338-renal-tubuler-akim-azalmasına-yanıt

Başlık: Renal tübüler akım azalmasına yanıt

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Makula densanın düşük sodyum klorür algısına renin salınımı yanıtını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde distal tübüle ulaşan sodyum klorür miktarı azaldığında juxtaglomerüler yanıtın ne olacağı tartışılıyor. Bilinen böbrek hastalığı yoktur. Değerlendirme tubuloglomerüler geri bildirim mekanizmasını anlamak için yapılmaktadır.

Demografi: 34 yaşında sağlıklı gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 114/72 mmHg | Nabız: 72/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,63

Fizik Muayene

- Fizik muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fizyolojik simülasyon

Etiket: Fizyolojik simülasyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Makula densaya ulaşan sodyum klorür miktarı azalmış olarak modellendi. | Klinik anlam: Juxtaglomerüler aparat yanıtını değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç yorumu: Juxtaglomerüler aparat yanıtını değerlendirmek için kullanılmıştır. | Sonuç başlığı: Fizyolojik simülasyon | Sonuç özeti: Makula densaya ulaşan sodyum klorür miktarı azalmış olarak modellendi. | Yorum: Juxtaglomerüler aparat yanıtını değerlendirmek için kullanılmıştır. | Satırlar: Fizyolojik simülasyon / Makula densaya ulaşan sodyum klorür miktarı azalmış olarak modellendi. // Juxtaglomerüler aparat yanıtını değerlendirmek için kullanılmıştır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu durumda beklenen temel yanıt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması
- B) Aldosteron salınımının kalıcı olarak sıfırlanması
- C) Antidiüretik hormon reseptörlerinin tamamen yıkılması
- D) Glomerüler filtrasyonun irreversibl durması
- E) Eritropoietin salınımının akut olarak baskılanması

Doğru Cevap: Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması

A) Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması: Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması düşük makula densa sodyum klorür sinyaline verilen doğru yanıttır. Vakadaki “Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.” ve “Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Aldosteron salınımının kalıcı olarak sıfırlanması: Aldosteron salınımının sıfırlanması bu durumda beklenmez; renin-anjiyotensin sistemi aldosteronu artırma eğilimindedir. Bu olguda “Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.” ve “Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Antidiüretik hormon reseptörlerinin tamamen yıkılması: Vakadaki Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır ve Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır. Bu olguda “Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.” ve “Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Glomerüler filtrasyonun irreversibl durması: Vakadaki Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır ve Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır. Bu olguda “Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.” ve “Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Eritropoietin salınımının akut olarak baskılanması: Eritropoietin salınımı oksijenlenme ile ilişkilidir; makula densa NaCl azalmasının temel akut yanıtı değildir. Bu olguda “Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.” ve “Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Renal tübüler akım azalmasına yanıt olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.” ve “Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.” birlikte okunduğunda Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması seçeneği öne çıkar; “Değerlendirme tubuloglomerüler geri bildirim bağlamındadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Makula densa distal tübüldeki sodyum klorür miktarını algılar. Düşük sodyum klorür, azalmış efektif dolaşım hacmi veya düşük filtrasyon sinyali olarak yorumlanır ve juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımını artırır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.”, “Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.” ve “Değerlendirme tubuloglomerüler geri bildirim bağlamındadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Juxtaglomerüler hücrelerden renin salınımının artması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Simülasyonda makula densaya ulaşan sodyum klorür azaltılmıştır.

Kanıt 2: Soru juxtaglomerüler aparat yanıtını sorgulamaktadır.

Kanıt 3: Değerlendirme tubuloglomerüler geri bildirim bağlamındadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Makula densa düşük NaCl algıladığında renin salınımı artar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 339: v195-new-339-uzamis-ekspiryum-ve-hava-hapsi

Başlık: Uzamış ekspiryum ve hava hapsi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Amfizemde akciğer kompliyansı artışını elastik recoil azalmasıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, uzun süredir artan efor dispnesi ve nefes verirken zorlanma nedeniyle başvuruyor. Kirk paket-yıl sigara öyküsü vardır. Son yıllarda göğüs kafesinin genişlediğini ve özellikle nefes verirken zorlandığını belirtmektedir.

Demografi: 62 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 84/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %92% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,71

Fizik Muayene

- Fiçi göğüs görünümü vardır.
- Ekspiyum uzamıştır.
- Perküyonda hipersonorite alınır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Solunum fonksiyon testi

Etiket: Solunum fonksiyon testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: FEV1/FVC oranı düşük, rezidüel volüm yüksek saptandı. | Klinik anlam: Obstrüktif patern ve hava hapsini destekler. | Sonuç yorumu: Obstrüktif patern ve hava hapsini destekler. | Sonuç başlığı: Solunum fonksiyon testi | Sonuç özeti: FEV1/FVC oranı düşük, rezidüel volüm yüksek saptandı. | Yorum: Obstrüktif patern ve hava hapsini destekler. | Satırlar: Solunum fonksiyon testi / FEV1/FVC oranı düşük, rezidüel volüm yüksek saptandı. // Obstrüktif patern ve hava hapsini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada akciğer mekanikleri açısından beklenen temel değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması
B) Akciğer kompliyansının azalması ve elastik recoil artması
C) Rezidüel volümün belirgin azalması
D) Hava yolu direncinin tamamen sıfırlanması
E) Alveoler ventilasyonun geri dönüşümsüz durması

Doğru Cevap: Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması

A) Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması: Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması amfizemde alveoler duvar yıkımının beklenen sonucudur. Vakadaki "Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır." ve "Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Akciğer kompliyansının azalması ve elastik recoil artması: Vakadaki Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır ve Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır." ve "Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Rezidüel volümün belirgin azalması: Vakadaki Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır ve Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır." ve "Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Hava yolu direncinin tamamen sıfırlanması: Vakadaki Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır ve Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır." ve "Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Alveoler ventilasyonun geri dönüşümsüz durması: Vakadaki Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır ve Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır." ve "Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzamış ekspiryum ve hava hapsi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır." ve "Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır." birlikte okunduğunda Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması seçeneği öne çıkar; "Solunum fonksiyon testinde hava hapsi ile uyumlu rezidüel volüm artışı vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Amfizemde alveoler duvar yıkımı elastik recoil gücünü azaltır. Akciğerler daha kolay genişler, kompliyans artar; ancak ekspiryumda hava yolları kollabe olma eğilimi gösterir ve hava hapsi gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır.", "Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır." ve "Solunum fonksiyon testinde hava hapsi ile uyumlu rezidüel volüm artışı vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akciğer kompliyansının artması ve elastik recoil azalması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada yoğun sigara öyküsü ve fiçi göğüs görünümü vardır.

Kanıt 2: Ekspiryum uzamış ve hipersonorite saptanmıştır.

Kanıt 3: Solunum fonksiyon testinde hava hapsi ile uyumlu rezidüel volüm artışı vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Amfizemde elastik recoil azalır, kompliyans artar ve hava hapsi gelişir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 340: v195-new-340-mesane-bosaltma-refleksi

Başlık: Mesane boşaltma refleksi

Branş: physiology | İlgili Branş: Fizyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Miksiyon refleksinde parasempatik S2-S4 liflerinin detrusor kontraksiyonunu sağlamasını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Gönüllüde mesane dolduğunda işeme refleksini başlatan otonom yolak tartışılıyor. Bilinen nörolojik hastalığı yoktur. Soru, normal miksiyon refleksinin efferent bileşenine yöneliktir.

Demografi: 45 yaşında erkek gönüllü | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fizik muayenesi doğaldır.
- Alt ekstremit motor ve duyu muayenesi normaldir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Fizyolojik simülasyon

Etiket: Fizyolojik simülasyon | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Mesane doluluğu artmış ve sakral parasempatik çıkış aktive edilmiş olarak modellendi. | Klinik anlam: Miksiyon refleksinin efferent yanıtını temsil eder. | Sonuç yorumu: Miksiyon refleksinin efferent yanıtını temsil eder. | Sonuç başlığı: Fizyolojik simülasyon | Sonuç özeti: Mesane doluluğu artmış ve sakral parasempatik çıkış aktive edilmiş olarak modellendi. | Yorum: Miksiyon refleksinin efferent yanıtını temsil eder. | Satırlar: Fizyolojik simülasyon / Mesane doluluğu artmış ve sakral parasempatik çıkış aktive edilmiş olarak modellendi. / / Miksiyon refleksinin efferent yanıtını temsil eder.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Miksiyon sırasında detrusor kasının kasılmasını sağlayan temel efferent yolak aşağıdakilerden hangisidir?

- A) S2-S4 parasempatik lifleri
B) T1-T4 sempatik lifleri
C) Nervus phrenicus
D) Nervus accessorius
E) Somatik pudendal liflerin detrusoru gevşetmesi

Doğru Cevap: S2-S4 parasempatik lifleri

A) S2-S4 parasempatik lifleri: S2-S4 parasempatik lifleri detrusor kontraksiyonunu sağlayarak miksiyonu başlatan temel efferent yoldur. Vakadaki "Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır." ve "Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) T1-T4 sempatik lifleri: Vakadaki Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır ve Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir. Bu olguda "Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır." ve "Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir." ipuçları klinik karar açısından S2-S4 parasempatik lifleri seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Nervus phrenicus: Vakadaki Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır ve Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir. Bu olguda "Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır." ve "Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir." ipuçları klinik karar açısından S2-S4 parasempatik lifleri seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Nervus accessorius: Vakadaki Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır ve Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir. Bu olguda "Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır." ve "Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir." ipuçları klinik karar açısından S2-S4 parasempatik lifleri seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Somatik pudendal liflerin detrusoru gevşetmesi: Somatik pudendal lifler dış üretral sfinkteri kontrol eder; detrusor kasılmasını doğrudan sağlamaz. Bu olguda "Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır." ve "Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir." ipuçları klinik karar açısından S2-S4 parasempatik lifleri seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Mesane boşaltma refleksi olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır." ve "Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir." birlikte okunduğunda S2-S4 parasempatik lifleri seçeneği öne çıkar; "Soru detrusor kasılmasının efferent yolunu sorgulamaktadır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Miksiyon refleksinde mesane doluluğu sakral merkezleri aktive eder. S2-S4 parasempatik lifleri detrusor kasını kasarken iç sfinkter gevşer; pudendal somatik kontrol dış sfinkter üzerinde etkilidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır.", "Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir." ve "Soru detrusor kasılmasının efferent yolunu sorgulamaktadır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle S2-S4 parasempatik lifleri en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Simülasyonda mesane doluluğu artırılmıştır.

Kanıt 2: Sakral parasempatik çıkış aktive edilmiştir.

Kanıt 3: Soru detrusor kasılmasının efferent yolunu sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Detrusor kasılması parasempatik S2-S4 lifleriyle sağlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: histology-embryology

VAKA 341: v195-new-341-katekolamin-salgılayan-hucre-kokeni

Başlık: Katekolamin salgılayan hücre kökeni

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Klinik veriyi hedeflenen karar noktasıyla eşleştirme.

Learning Target: Adrenal medullanın nöral krest kökenini kromaffin hücreleri üzerinden tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hastada adrenal medulladaki katekolamin salgılayan hücrelerin embriyolojik kökeni tartışılıyor. Paroksizmal hipertansiyon atakları nedeniyle adrenal değerlendirme planlandığı öğreniliyor. Soru, adrenal medullanın hücresel kökenine yöneliktir.

Demografi: 46 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Fizik muayenede belirgin akut bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Adrenal histoloji bilgisi

Etiket: Adrenal histoloji bilgisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Medullada granüllü sitoplazmalı kromaffin hücreleri tanımlandı. | Klinik anlam: Katekolamin salgılayan adrenal medulla hücrelerini gösterir. | Sonuç yorumu: Katekolamin salgılayan adrenal medulla hücrelerini gösterir. | Sonuç başlığı: Adrenal histoloji bilgisi | Sonuç özeti: Medullada granüllü sitoplazmalı kromaffin hücreleri tanımlandı. | Yorum: Katekolamin salgılayan adrenal medulla hücrelerini gösterir. | Satırlar: Adrenal histoloji bilgisi / Medullada granüllü sitoplazmalı kromaffin hücreleri tanımlandı. // Katekolamin salgılayan adrenal medulla hücrelerini gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-175 | Başlık: Adrenal histoloji bilgisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Medullada granüllü sitoplazmalı kromaffin hücreleri tanımlandı. | Klinik anlam: Katekolamin salgılayan adrenal medulla hücrelerini gösterir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/175_adrenal_medulla_kromaffin_hucre_histoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/175_adrenal_medulla_kromaffin_hucre_histoloji.webp | Alt text: Adrenal histoloji bilgisi - Medullada granüllü sitoplazmalı kromaffin hücreleri tanımlandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hücrelerin embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nöral krest
B) Endoderm
C) Ara mezoderm
D) Paraksiyal mezoderm
E) Yüzey ektodermi

Doğru Cevap: Nöral krest

A) Nöral krest: Nöral krest adrenal medulla kromaffin hücrelerinin kökenidir ve katekolamin salgılayan sempatoadrenal yapıyı açıklar. Vakadaki “Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.” ve “Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Endoderm: Endoderm gastrointestinal ve solunum epiteli gibi yapılara katkı verir; adrenal medulla kökeni değildir. Bu olguda “Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.” ve “Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Nöral krest seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Ara mezoderm: Vakadaki Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır ve Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır. Bu olguda “Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.” ve “Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Nöral krest seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Paraksiyal mezoderm: Vakadaki Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır ve Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır. Bu olguda “Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.” ve “Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Nöral krest seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Yüzey ektodermi: Yüzey ektodermi epidermis ve bazı duyu epitellerine katkı verir; adrenal medulla kökeni değildir. Bu olguda “Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.” ve “Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.” ipuçları klinik karar açısından Nöral krest seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Katekolamin salgılayan hücre kökeni olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.” ve “Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.” birlikte okunduğunda Nöral krest seçeneği öne çıkar; “Bu hücreler katekolamin salgısıyla ilişkilidir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Adrenal medulla kromaffin hücreleri modifiye postganglionik sempatik nöronlar gibi davranır ve nöral krest kökenlidir. Katekolamin salgılamaları bu sempatoadrenal kökenle uyumludur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.”, “Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.” ve “Bu hücreler katekolamin salgısıyla ilişkilidir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nöral krest en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Soru adrenal medulla hücrelerini sorgulamaktadır.

Kanıt 2: Histolojide kromaffin hücreleri tanımlanmıştır.

Kanıt 3: Bu hücreler katekolamin salgısıyla ilişkilidir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Adrenal medulla nöral krest kökenlidir; adrenal korteks mezoderm kökenlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 342: v195-new-342-tekrarlayan-kirik-ve-mavi-sklera

Başlık: Tekrarlayan kırık ve mavi sklera

Branş: histology-embryology | İlgili Branş: Histoloji ve Embriyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Tip I kollajen bozukluğunu osteogenesis imperfecta bulgularıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, tekrarlayan düşük enerjili kırıklar ve göz aklarında mavilik nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun yürümeye başladıktan sonra birkaç kez hafif travmayla kırık geçirdiğini belirtmektedir. İditme azalması şüphesi de vardır.

Demografi: 6 yaşında kız çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Mavi sklera belirgindir.
- Ekstremitelerde eski kırıklara bağlı hafif şekil değişiklikleri vardır.
- Dişlerde opalesan görünüm izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Genetik analiz

Etiket: Genetik analiz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: COL1A1 geninde patojenik varyant saptandı. | Klinik anlam: Tip I kollajen bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Tip I kollajen bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Genetik analiz | Sonuç özeti: COL1A1 geninde patojenik varyant saptandı. | Yorum: Tip I kollajen bozukluğunu destekler. | Satırlar: Genetik analiz / COL1A1 geninde patojenik varyant saptandı. // Tip I kollajen bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel yapısal protein bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tip I kollajen
B) Tip II kollajen
C) Tip IV kollajen
D) Elastin
E) Fibrillin-1

Doğru Cevap: Tip I kollajen

A) Tip I kollajen: Tip I kollajen kemik, dentin ve sklerada önemli olduğu için kırık, diş bulgusu ve mavi sklerayı açıklar. Vakadaki “Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.” ve “Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Tip II kollajen: Tip II kollajen kıkırdak ve vitreus yapısında önemlidir; bu klasik kırılma kemik tablosunun ana proteini değildir. Bu olguda “Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.” ve “Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Tip I kollajen seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Tip IV kollajen: Tip IV kollajen bazal membranlarda bulunur; tekrarlayan kırık ve mavi sklera paternini açıklamaz. Bu olguda “Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.” ve “Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Tip I kollajen seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Elastin: Vakadaki Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır ve Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir. Bu olguda “Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.” ve “Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Tip I kollajen seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Fibrillin-1: Vakadaki Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır ve Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir. Bu olguda “Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.” ve “Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.” ipuçları anatomik lokalizasyon açısından Tip I kollajen seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tekrarlayan kırık ve mavi sklera olgusunda klinik karar anatomik lokalizasyon üzerine kuruludur. “Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.” ve “Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Tip I kollajen seçeneği öne çıkar; “COL1A1 geninde patojenik varyant saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Osteogenesis imperfecta tip I kollajen sentez veya yapı bozukluğuna bağlıdır. Kemik kırılabilirliği, mavi sklera, dentinogenesis imperfecta ve işitme kaybı gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.”, “Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.” ve “COL1A1 geninde patojenik varyant saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Tip I kollajen en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocukta hafif travmayla tekrarlayan kırıklar vardır.

Kanıt 2: Mavi sklera ve diş bulguları izlenmiştir.

Kanıt 3: COL1A1 geninde patojenik varyant saptanmıştır.

Core Knowledge: Anatomi temelli klinik sorularda lokalizasyon; motor kayıp, duyu alanı, cerrahi/travma bölgesi ve komşuluk ilişkilerinin birlikte yorumlanmasıyla yapılır. Yakın çeldiriciler, beklenen fonksiyon kaybı veya anatomik seyir olguya uyuşmadığında elenir.

Exam Pearl: Osteogenesis imperfecta tip I kollajen bozukluğudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-biochemistry

VAKA 343:

v195-new-343-erkek-cocukta-kendini-isirma-ve-urik-asit-yuksekligi

Başlık: Erkek çocukta kendini ısırma ve ürik asit yüksekliği

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Lesch-Nyhan sendromunda HGPRT eksikliğini hiperürisemi ve kendine zarar verme davranışıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, gelişim geriliği, istemsiz hareketler ve dudak-parmak ısırma davranışı nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun motor gelişiminin geciktiğini, son aylarda kendine zarar verici ısırma davranışlarının arttığını ve bezinde turuncu-kum benzeri kristaller gördüklerini belirtmektedir.

Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Distoni ve koreoatetoz benzeri hareketler izlenir.
- Dudaklarda ısırmağa bağlı yara izleri vardır.
- Hafif hipotonisi mevcuttur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum ürik asit

Etiket: Serum ürik asit | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Pürin yıkım ürünlerinin arttığını destekler. | Sonuç yorumu: Pürin yıkım ürünlerinin arttığını destekler. | Sonuç başlığı: Serum ürik asit | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Pürin yıkım ürünlerinin arttığını destekler. | Satırlar: Serum ürik asit / 10.8 mg/dL / 2.5-6.0 mg/dL / Pürin yıkım ürünlerinin arttığını destekler.

Tetkik 2: Eritrosit enzim analizi

Etiket: Eritrosit enzim analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: HGPRT aktivitesi belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Pürin kurtarma yolu bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Pürin kurtarma yolu bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Eritrosit enzim analizi | Sonuç özeti: HGPRT aktivitesi belirgin düşük saptandı. | Yorum: Pürin kurtarma yolu bozukluğunu destekler. | Satırlar: Eritrosit enzim analizi / HGPRT aktivitesi belirgin düşük saptandı. / Pürin kurtarma yolu bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıktaki temel biyokimyasal bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği
- B) Bakırın safra ile atılımında bozukluk
- C) Fruktoz-1-fosfat yıkımında bozukluk
- D) Nötral aminoasit taşınmasında bozukluk
- E) GM2 gangliozid yıkımında bozukluk

Doğru Cevap: Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği

- A) Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği: Pürin kurtarma yolunda HGPRT eksikliği hiperürisemi, nörolojik bulgular ve kendine zarar verme davranışını açıklar. Vakadaki “Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.” ve “Kendini ısırma davranışı belirgindir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekçelenir.
- B) Bakırın safra ile atılımında bozukluk: Bakırın safra ile atılım bozukluğu karaciğer ve nörolojik bulgular yapabilir ancak HGPRT düşükliğini açıklamaz. Bu olguda “Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.” ve “Kendini ısırma davranışı belirgindir.” ipuçları klinik karar açısından Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Fruktoz-1-fosfat yıkımında bozukluk: Fruktoz-1-fosfat yıkım bozukluğu fruktoz alımı sonrası hipoglisemi ve karaciğer bulguları yapar. Bu olguda “Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.” ve “Kendini ısırma davranışı belirgindir.” ipuçları klinik karar açısından Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Nötral aminoasit taşınmasında bozukluk: Nötral aminoasit taşıma bozukluğu pellagra benzeri bulgularla ilişkilidir; hiperürisemi ve kendini ısırma paternini açıklamaz. Bu olguda “Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.” ve “Kendini ısırma davranışı belirgindir.” ipuçları klinik karar açısından Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) GM2 gangliozid yıkımında bozukluk: GM2 gangliozid yıkım bozukluğu nörodejenerasyon yapar ancak ürik asit yüksekliği ve HGPRT eksikliği beklenmez. Bu olguda “Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.” ve “Kendini ısırma davranışı belirgindir.” ipuçları klinik karar açısından Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erkek çocukta kendini ısırma ve ürik asit yüksekliği olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.” ve “Kendini ısırma davranışı belirgindir.” birlikte okunduğunda Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği seçeneği öne çıkar; “Serum ürik asit yüksek ve HGPRT aktivitesi düşüktür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Lesch-Nyhan sendromunda HGPRT eksikliği pürin kurtarma yolunu bozar. Hipoksantin ve guanin geri kazanılamaz, ürik asit üretimi artar; nörolojik bulgular ve kendine zarar verme davranışı gelişir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.”, “Kendini ısırma davranışı belirgindir.” ve “Serum ürik asit yüksek ve HGPRT aktivitesi düşüktür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pürin kurtarma yolunda hipoksantin-guanin fosforiboziltransferaz eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta erkek çocuktur ve nörolojik gelişim geriliği vardır.

Kanıt 2: Kendini ısırma davranışı belirgindir.

Kanıt 3: Serum ürik asit yüksek ve HGPRT aktivitesi düşüktür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Lesch-Nyhan sendromu HGPRT eksikliği, hiperürisemi ve kendine zarar verme davranışıyla tanınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 344: v195-new-344-makrositoz-ve-norolojik-yakinma

Başlık: Makrositoz ve nörolojik yakınma

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Metiyonin sentaz reaksiyonunda vitamin B12 ve folat ilişkisini megaloblastik anemiyle açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, halsizlik, dilde yanma ve ayaklarda uyuşma nedeniyle başvuruyor. Uzun süredir hayvansal gıda tüketmediği ve son aylarda yürümeye dengesizlik yaşadığı öğreniliyor. Alkol kullanımı yoktur.

Demografi: 58 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Dil kırmızı ve hassastır.
- Alt ekstremitelerde vibrasyon duyusu azalmıştır.
- Hafif ataksik yürüyüş izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: MCV

Etiket: MCV | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Makrositozu gösterir. | Sonuç yorumu: Makrositozu gösterir. | Sonuç başlığı: MCV | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Makrositozu gösterir. | Satırlar: MCV / 114 fL / 80-100 fL / Makrositozu gösterir.

Tetkik 2: Serum vitamin B12

Etiket: Serum vitamin B12 | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kobalamin eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: Kobalamin eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum vitamin B12 | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kobalamin eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum vitamin B12 / Düşük saptandı. // Kobalamin eksikliğini destekler.

Tetkik 3: Homocysteine

Etiket: Homocysteine | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Metiyonin sentaz reaksiyonu bozukluğunu destekler. | Sonuç yorumu: Metiyonin sentaz reaksiyonu bozukluğunu destekler. | Sonuç başlığı: Homocysteine | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Metiyonin sentaz reaksiyonu bozukluğunu destekler. | Satırlar: Homocysteine / Yüksek saptandı. // Metiyonin sentaz reaksiyonu bozukluğunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Vitamin B12 eksikliğinde homosisteinin yükselmesine yol açan temel reaksiyon bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması
B) Fenilalaninin homogentisik aside dönüşümünün artması
C) Glukozun laktata dönüşümünün tamamen durması
D) Ürik asidin allantoin üzerinden yıkılması
E) Safra asitlerinin kolesterole dönüşmesi

Doğru Cevap: Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması

A) Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması: Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması vitamin B12 eksikliğinde homosistein yüksekliğini açıklar. Vakadaki "Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır." ve "Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Fenilalaninin homogentisik aside dönüşümünün artması: Fenilalaninin homogentisik aside dönüşümü tirozin katabolizmasıyla ilişkilidir; B12-homosistein ilişkisini açıklamaz. Bu olguda "Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır." ve "Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir." ipuçları klinik karar açısından Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Glukozun laktata dönüşümünün tamamen durması: Vakadaki Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır ve Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir. Bu olguda "Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır." ve "Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir." ipuçları klinik karar açısından Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Ürik asidin allantoin üzerinden yıkılması: İnsanlarda ürik asit allantoin üzerinden yıkılmaz; bu reaksiyon homosistein yüksekliğini açıklayamaz. Bu olguda "Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır." ve "Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir." ipuçları klinik karar açısından Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Safra asitlerinin kolesterole dönüşmesi: Safra asitleri kolesterolden sentezlenir; kolesterole dönüşmeleri bu tabloyla ilişkili değildir. Bu olguda "Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır." ve "Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir." ipuçları klinik karar açısından Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Makrositoz ve nörolojik yakınma olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır." ve "Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir." birlikte okunduğunda Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması seçeneği öne çıkar; "Homocysteine düzeyi yüksek saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Vitamin B12, metiyonin sentaz reaksiyonunda metilfolatla birlikte homosisteinin metiyonine dönüşümü için gereklidir. Eksiklikte homosistein yükselir; folat tuzaklanması DNA sentezini bozarak megaloblastik anemiye katkı sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır.", "Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir." ve "Homocysteine düzeyi yüksek saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Homosisteinin metiyonine dönüşümünün azalması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada makrositoz ve düşük vitamin B12 düzeyi vardır.

Kanıt 2: Nörolojik bulgular kobalamin eksikliğini desteklemektedir.

Kanıt 3: Homocysteine düzeyi yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: B12 eksikliğinde homosistein ve metilmalonik asit artar; folat eksikliğinde metilmalonik asit artmaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 345: v195-new-345-yenidoganda-beslenme-sonrasi-asidoz

Başlık: Yenidoğanda beslenme sonrası asidoz

Branş: medical-biochemistry | İlgili Branş: Tıbbi Biyokimya | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Propiyonik asidemide propiyonil-KoA karboksilaz bozukluğunu metabolik asidoz ve hiperammonemiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, beslenme sonrası kusma, letarji ve hızlı solunum nedeniyle yatırılıyor. İlk günlerde belirgin sorunu olmadığı, proteinli beslenme arttıkça kötüleştiği öğreniliyor. Ailede benzer dönemde kaybedilen bebek öyküsü vardır.

Demografi: 8 günlük kız yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve dehidrate görünmektedir.
- Takipne vardır.
- Hepatomegali hafiftir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan gazı

Etiket: Kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Organik asidemi paternini destekler. | Sonuç yorumu: Organik asidemi paternini destekler. | Sonuç başlığı: Kan gazı | Sonuç özeti: Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Organik asidemi paternini destekler. | Satırlar: Kan gazı / pH 7.18, HCO₃ 10 mmol/L // Organik asidemi paternini destekler.

Tetkik 2: Plazma amonyak

Etiket: Plazma amonyak | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Sekonder hiperammonemi destekler. | Sonuç yorumu: Sekonder hiperammonemi destekler. | Sonuç başlığı: Plazma amonyak | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Sekonder hiperammonemi destekler. | Satırlar: Plazma amonyak / 210 µmol/L / <80 µmol/L / Sekonder hiperammonemi destekler.

Tetkik 3: Açıl-karnitin profili

Etiket: Açıl-karnitin profili | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: C3 propiyonilkarnitin artışı saptandı. | Klinik anlam: Propiyonik asidemi lehinedir. | Sonuç yorumu: Propiyonik asidemi lehinedir. | Sonuç başlığı: Açıl-karnitin profili | Sonuç özeti: C3 propiyonilkarnitin artışı saptandı. | Yorum: Propiyonik asidemi lehinedir. | Satırlar: Açıl-karnitin profili / C3 propiyonilkarnitin artışı saptandı. // Propiyonik asidemi lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta en olası enzim defekti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği
B) Heksozaminidaz A eksikliği
C) Aldolaz B eksikliği
D) HGPRT eksikliği
E) Glukokinaz eksikliği

Doğru Cevap: Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği

A) Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği: Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği C3 propiyonilkarnitin artışı ve organik asidemi tablosunu açıklar. Vakadaki “Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.” ve “Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Heksozaminidaz A eksikliği: Heksozaminidaz A eksikliği nörodegeneratif lizozomal depo hastalığıyla ilişkilidir; organik asidemi yapmaz. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.” ve “Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Aldolaz B eksikliği: Vakadaki Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir ve Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.” ve “Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

D) HGPRT eksikliği: HGPRT eksikliği pürin kurtarma yolu bozukluğuna bağlı hiperürisemi ve nörolojik davranış bulguları yapar. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.” ve “Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Glukokinaz eksikliği: Glukokinaz eksikliği glukoz algılama ve MODY alt tiptiyle ilişkilidir; C3 artışı asidozu açıklayamaz. Bu olguda “Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.” ve “Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda beslenme sonrası asidoz olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.” ve “Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.” birlikte okunduğunda Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği seçeneği öne çıkar; “Açıl-karnitin profilinde C3 propiyonilkarnitin artmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Propiyonik asidemide propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği propiyonil-KoA metabolizmasını bozar. Yenidoğanda beslenme sonrası yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz, ketozis ve hiperammonemi gelişebilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.”, “Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.” ve “Açıl-karnitin profilinde C3 propiyonilkarnitin artmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Propiyonil-KoA karboksilaz eksikliği en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Semptomlar yenidoğan döneminde proteinli beslenme sonrası belirginleşmiştir.

Kanıt 2: Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz vardır.

Kanıt 3: Açıl-karnitin profilinde C3 propiyonilkarnitin artmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Propiyonik asidemi organik asidemi tablosu yapar ve C3 açıl-karnitin artışıyla desteklenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-microbiology

VAKA 346: v195-new-346-dalgali-ates-ve-bel-agrisi

Başlık: Dalgali ateş ve bel ağrısı

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Brucella enfeksiyonunu pastörize edilmemiş süt ürünü maruziyeti ve dalgali ateşle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, haftalardır süren dalgali ateş, gece terlemesi ve bel ağrısı nedeniyle başvuruyor. Kırsal bölgede yaşadığı, keçi peyniri gibi pastörize edilmemiş süt ürünleri tükettiği öğreniliyor. İştahsızlık ve halsizlik eşlik etmektedir.

Demografi: 41 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/72 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Hafif hepatosplenomegali vardır.
- Bel hareketleri ağrılıdır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Standart tüp aglütinasyon testi

Etiket: Standart tüp aglütinasyon testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Brucella için pozitif saptandı. | Klinik anlam: Brusellozu destekler. | Sonuç yorumu: Brusellozu destekler. | Sonuç başlığı: Standart tüp aglütinasyon testi | Sonuç özeti: Brucella için pozitif saptandı. | Yorum: Brusellozu destekler. | Satırlar: Standart tüp aglütinasyon testi / Brucella için pozitif saptandı. // Brusellozu destekler.

Tetkik 2: Kan kültürü

Etiket: Kan kültürü | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Küçük gram-negatif kokobasil üremesi bildirildi. | Klinik anlam: Etkenle uyumlu olabilir. | Sonuç yorumu: Etkenle uyumlu olabilir. | Sonuç başlığı: Kan kültürü | Sonuç özeti: Küçük gram-negatif kokobasil üremesi bildirildi. | Yorum: Etkenle uyumlu olabilir. | Satırlar: Kan kültürü / Küçük gram-negatif kokobasil üremesi bildirildi. // Etkenle uyumlu olabilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Brucella melitensis
B) Vibrio vulnificus
C) Bacillus cereus
D) Clostridium botulinum
E) Shigella sonnei

Doğru Cevap: Brucella melitensis

A) Brucella melitensis: Brucella melitensis pastörize edilmemiş keçi-koyun ürünleri sonrası dalgali ateş ve sistemik bulgularla en uyumludur. Vakadaki "Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir." ve "Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Vibrio vulnificus: Vibrio vulnificus deniz ürünü veya deniz suyu maruziyetiyle selülit ve sepsis yapabilir; süt ürünü ilişkili dalgali ateşi açıklamaz. Bu olguda "Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir." ve "Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır." ipuçları tanısallık açısından Brucella melitensis seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Bacillus cereus: Bacillus cereus kısa inkübasyonlu gıda zehirlenmesi yapar; haftalar süren dalgali ateş beklenmez. Bu olguda "Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir." ve "Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır." ipuçları tanısallık açısından Brucella melitensis seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Clostridium botulinum: Clostridium botulinum gevşek paralizi yapar; hepatosplenomegali ve dalgali ateş paternini açıklamaz. Bu olguda "Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir." ve "Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır." ipuçları tanısallık açısından Brucella melitensis seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Shigella sonnei: Shigella sonnei invaziv ishale neden olur; pastörize edilmemiş süt ürünü sonrası kronik sistemik tablo için uygun değildir. Bu olguda "Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir." ve "Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır." ipuçları tanısallık açısından Brucella melitensis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Dalgali ateş ve bel ağrısı olgusunda klinik karar tanısallık kararı üzerine kuruludur. "Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir." ve "Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır." birlikte okunduğunda Brucella melitensis seçeneği öne çıkar; "Brucella aglütinasyon testi pozitif saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Pastörize edilmemiş süt ürünü tüketimi, dalgali ateş, gece terlemesi, hepatosplenomegali ve bel ağrısı brusellozu düşündürür. Brucella melitensis özellikle keçi-koyun kaynaklı bulaşla ilişkilidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir.", "Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır." ve "Brucella aglütinasyon testi pozitif saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Brucella melitensis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta pastörize edilmemiş süt ürünü tüketmiştir.

Kanıt 2: Dalgali ateş ve gece terlemesi vardır.

Kanıt 3: Brucella aglütinasyon testi pozitif saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Brusellozda pastörize edilmemiş süt ürünleri ve dalgali ateş klasik ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 347: v195-new-347-akciger-ve-beyin-lezyonlari

Başlık: Akciğer ve beyin lezyonları

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Nocardia enfeksiyonunu zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteri ve immünsüpresyonla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, öksürük, ateş ve yeni başlayan baş ağrısı nedeniyle yatırılıyor. Böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi aldığı öğreniliyor. Son haftalarda kuru öksürük ve kilo kaybı gelişmiş, son günlerde baş ağrısı ve hafif sağ kol güçsüzlüğü eklenmiştir.

Demografi: 50 yaşında erkek hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.2°C | Şok indeksi: 0,92 (sınırdı yüksek)

Fizik Muayene

- Akciğer sağ üst alanda raller duyulur.
- Nörolojik muayenede sağ üst ekstremitede hafif güçsüzlük vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Balgam modifiye aside dirençli boyama

Etiket: Balgam modifiye aside dirençli boyama | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteriler izlendi. | Klinik anlam: Nocardia enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Nocardia enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Balgam modifiye aside dirençli boyama | Sonuç özeti: Zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteriler izlendi. | Yorum: Nocardia enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Balgam modifiye aside dirençli boyama / Zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteriler izlendi. // Nocardia enfeksiyonunu destekler.

Tetkik 2: Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme

Etiket: Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Beyinde halka tarzı kontrastlanan lezyonlar izlendi. | Klinik anlam: Dissemine enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Dissemine enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme | Sonuç özeti: Beyinde halka tarzı kontrastlanan lezyonlar izlendi. | Yorum: Dissemine enfeksiyon olasılığını destekler. | Satırlar: Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme / Beyinde halka tarzı kontrastlanan lezyonlar izlendi. // Dissemine enfeksiyon olasılığını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-176 | Başlık: Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme | Modalite: mri | Bulgu: Beyinde halka tarzı kontrastlanan lezyonlar izlendi. | Klinik anlam: Dissemine enfeksiyon olasılığını destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/176_halka_kontrastlanan_beyin_lezyonlari_mr.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/176_halka_kontrastlanan_beyin_lezyonlari_mr.webp | Alt text: Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme - Beyinde halka tarzı kontrastlanan lezyonlar izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nocardia asteroides kompleksi
B) Actinomyces israelii
C) Mycoplasma pneumoniae
D) Streptococcus agalactiae
E) Neisseria lactamica

Doğru Cevap: Nocardia asteroides kompleksi

- A) Nocardia asteroides kompleksi: Nocardia asteroides kompleksi immünsüpresyon, akciğer-beyin tutulumu ve zayıf aside dirençli dallanan filamentli yapı ile en uyumlu etkidir. Vakadaki "Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır." ve "Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- B) Actinomyces israelii: Actinomyces israelii anaerobik dallanan bakteridir ve genellikle aside dirençli değildir; servikofasiyal kitle ve sülfür granülleriyle ilişkilidir. Bu olguda "Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır." ve "Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nocardia asteroides kompleksi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Mycoplasma pneumoniae: Mycoplasma pneumoniae hücre duvarı olmayan atipik pnömoni etkenidir; filamentli aside dirençli yapı oluşturmaz. Bu olguda "Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır." ve "Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nocardia asteroides kompleksi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Streptococcus agalactiae: Streptococcus agalactiae yenidoğan enfeksiyonlarıyla ilişkilidir; zayıf aside dirençli filamentli bakteri değildir. Bu olguda "Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır." ve "Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nocardia asteroides kompleksi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Neisseria lactamica: Neisseria lactamica genellikle kommensaldir ve diplokok morfolojidedir; dallanan filamentli patern göstermez. Bu olguda "Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır." ve "Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir." ipuçları tanısız karar açısından Nocardia asteroides kompleksi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Akciğer ve beyin lezyonları olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır." ve "Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda Nocardia asteroides kompleksi seçeneği öne çıkar; "Boyamada zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteriler görülmüştür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Immünsüprese hastada akciğer enfeksiyonu ile beyin apsesi birlikteliği ve zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteriler Nocardia enfeksiyonunu düşündürür. Nocardia aerobiktir ve dissemine hastalık yapabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.", "Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir." ve "Boyamada zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteriler görülmüştür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nocardia asteroides kompleksi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hasta böbrek nakli nedeniyle immünsüpresif tedavi kullanmaktadır.

Kanıt 2: Akciğer bulgularına beyin lezyonları eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Boyamada zayıf aside dirençli dallanan filamentli bakteriler görülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Nocardia zayıf aside dirençli, aerobik, dallanan filamentli bakteridir ve immünsüprese hastada beyin apsesi yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 348: v195-new-348-seyahat-sonrasi-periyodik-ates

Başlık: Seyahat sonrası periyodik ateş

Branş: medical-microbiology | İlgili Branş: Tıbbi Mikrobiyoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Etkeni klinik ve laboratuvar ipuçlarıyla seçme.

Learning Target: Sıtmaı periyodik ateş ve eritrosit içi halkasal formlarla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, Afrika seyahati sonrası tekrarlayan ateş, titreme ve terleme atakları nedeniyle başvuruyor. Üç hafta önce sıtma profilaksisi kullanmadan kırsal bölgede bulunduğu öğreniliyor. Ateş ataklarının titreme ile başlayıp yüksek ateş ve terleme ile sonlandığını belirtmektedir.

Demografi: 33 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Muayene sırasında ateşi 39.1°C'dir.
- Hafif splenomegali vardır.
- Skleralarda hafif ikter izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kalın damla ve ince yayma

Etiket: Kalın damla ve ince yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Eritrositler içinde halkasal trofozoit formları izlendi. | Klinik anlam: Sıtma enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Sıtma enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Kalın damla ve ince yayma | Sonuç özeti: Eritrositler içinde halkasal trofozoit formları izlendi. | Yorum: Sıtma enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: Kalın damla ve ince yayma / Eritrositler içinde halkasal trofozoit formları izlendi. // Sıtma enfeksiyonunu destekler.

Tetkik 2: Hemogloblin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Hemolizi destekler. | Sonuç yorumu: Hemolizi destekler. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Hemolizi destekler. | Satırlar: Hemoglobin / 10.4 g/dL / 13.5-17.5 g/dL / Hemolizi destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-177 | Başlık: Kalın damla ve ince yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Eritrositler içinde halkasal trofozoit formları izlendi. | Klinik anlam: Sıtma enfeksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/177_plazmodium_halkasal_trofozoit_periferik_yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/177_plazmodium_halkasal_trofozoit_periferik_yayma.webp | Alt text: Kalın damla ve ince yayma - Eritrositler içinde halkasal trofozoit formları izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu klinik tabloya en olası neden olan parazit grubu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Plasmodium türleri
B) Echinococcus türleri
C) Enterobius vermicularis
D) Trichomonas vaginalis
E) Toxocara canis

Doğru Cevap: Plasmodium türleri

A) Plasmodium türleri: Plasmodium türleri endemik seyahat sonrası periyodik ateş ve eritrosit içi halkasal formlarla en uyumlu parazitlerdir. Vakadaki “Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.” ve “Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Echinococcus türleri: Vakadaki Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir ve Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir. Bu olguda “Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.” ve “Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.” ipuçları tanısalar karar açısından Plasmodium türleri seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Enterobius vermicularis: Vakadaki Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir ve Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir. Bu olguda “Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.” ve “Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.” ipuçları tanısalar karar açısından Plasmodium türleri seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Trichomonas vaginalis: Vakadaki Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir ve Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir. Bu olguda “Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.” ve “Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.” ipuçları tanısalar karar açısından Plasmodium türleri seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Toxocara canis: Toxocara canis visseral veya oküler larva migrans yapabilir; tipik sıtma yayma bulgusunu oluşturmaz. Bu olguda “Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.” ve “Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.” ipuçları tanısalar karar açısından Plasmodium türleri seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Seyahat sonrası periyodik ateş olgusunda klinik karar tanısalar karar üzerine kuruludur. “Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.” ve “Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.” birlikte okunduğunda Plasmodium türleri seçeneği öne çıkar; “Kan yaymasında eritrosit içi halkasal formlar izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Endemik bölge seyahati sonrası titreme-ateş-terleme paroksizmleri, hemoliz bulguları ve eritrosit içi halkasal trofozoitler sıtmaı düşündürür. Etken Plasmodium türleridir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.”, “Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.” ve “Kan yaymasında eritrosit içi halkasal formlar izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Plasmodium türleri en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta sıtma profilaksisi almadan endemik bölgeye seyahat etmiştir.

Kanıt 2: Titreme, yüksek ateş ve terleme atakları tariflenmiştir.

Kanıt 3: Kan yaymasında eritrosit içi halkasal formlar izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Sıtma tanısında kalın damla ve ince yaymada eritrosit içi parazitlerin gösterilmesi önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pathology

VAKA 349: v195-new-349-eriskinde-nefrotik-proteinuri

Başlık: Erişkinde nefrotik proteinüri

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Membranöz nefropatide subepitelyal immün kompleks birikimi ve spike görünümünü tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacaklarda şişlik ve köpüklü idrar nedeniyle başvuruyor. Son aylarda kilo alımı ve göz kapaklarında şişlik fark ettiğini belirtmektedir. Diyabet öyküsü yoktur. Sistemik enfeksiyon bulgusu tariflememektedir.

Demografi: 47 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 132/84 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,82

Fizik Muayene

- Bilateral pretibial ödem vardır.
- Akut artrit veya döküntü saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: 24 saatlik idrar protein düzeyi

Etiket: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Klinik anlam: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç yorumu: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç başlığı: 24 saatlik idrar protein düzeyi | Sonuç özeti: Nefrotik düzeyde proteinüri saptandı. | Yorum: Nefrotik sendromu destekler. | Satırlar: 24 saatlik idrar protein düzeyi / 6.2 g/gün / <0.15 g/gün / Nefrotik sendromu destekler.

Tetkik 2: Böbrek biyopsisi

Etiket: Böbrek biyopsisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Glomerüler bazal membranda yaygın kalınlaşma ve gümüş boyada spike görünümü izlendi. | Klinik anlam: Membranöz nefropati lehinedir. | Sonuç yorumu: Membranöz nefropati lehinedir. | Sonuç başlığı: Böbrek biyopsisi | Sonuç özeti: Glomerüler bazal membranda yaygın kalınlaşma ve gümüş boyada spike görünümü izlendi. | Yorum: Membranöz nefropati lehinedir. | Satırlar: Böbrek biyopsisi / Glomerüler bazal membranda yaygın kalınlaşma ve gümüş boyada spike görünümü izlendi. // Membranöz nefropati lehinedir.

Tetkik 3: İmmünfloresan

Etiket: İmmünfloresan | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi izlendi. | Klinik anlam: İmmün kompleks birikimini destekler. | Sonuç yorumu: İmmün kompleks birikimini destekler. | Sonuç başlığı: İmmünfloresan | Sonuç özeti: Kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi izlendi. | Yorum: İmmün kompleks birikimini destekler. | Satırlar: İmmünfloresan / Kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi izlendi. // İmmün kompleks birikimini destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-178 | Başlık: Böbrek biyopsisi | Modalite: microscopy | Bulgu: Glomerüler bazal membranda yaygın kalınlaşma ve gümüş boyada spike görünümü izlendi. | Klinik anlam: Membranöz nefropati lehinedir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/178_membranoz_nefropati_spike_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/178_membranoz_nefropati_spike_histopatoloji.webp | Alt text: Böbrek biyopsisi - Glomerüler bazal membranda yaygın kalınlaşma ve gümüş boyada spike görünümü izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-179 | Başlık: İmmünfloresan | Modalite: microscopy | Bulgu: Kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi izlendi. | Klinik anlam: İmmün kompleks birikimini destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/179_membranoz_nefropati_granuler_if.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/179_membranoz_nefropati_granuler_if.webp | Alt text: İmmünfloresan - Kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası patolojik tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Membranöz nefropati
B) Akut tübüler nekroz
C) Kresentik glomerülonefrit
D) Medüller sünger böbrek
E) Basit renal kist

Doğru Cevap: Membranöz nefropati

A) Membranöz nefropati: Membranöz nefropati nefrotik proteinüri, granüler kapiller duvar boyanması ve spike görünümüyle en uyumlu patolojik tanıdır. Vakadaki “Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.” ve “Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Akut tübüler nekroz: Akut tübüler nekroz tübüler epitel hasarı ve akut böbrek hasarıyla seyreder; glomerüler spike görünümü yapmaz. Bu olguda “Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.” ve “Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Membranöz nefropati seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Kresentik glomerülonefrit: Kresentik glomerülonefrit hızlı ilerleyen nefritik tablo ve kresentlerle ilişkilidir; bu olguda nefrotik patern baskındır. Bu olguda “Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.” ve “Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Membranöz nefropati seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Medüller sünger böbrek: Medüller sünger böbrek toplayıcı kanal dilatasyonlarıyla ilişkilidir; immün kompleks nefropatisi değildir. Bu olguda “Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.” ve “Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Membranöz nefropati seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Basit renal kist: Vakadaki Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır ve Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir. Bu olguda “Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.” ve “Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Membranöz nefropati seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erişkinde nefrotik proteinüri olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.” ve “Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.” birlikte okunduğunda Membranöz nefropati seçeneği öne çıkar; “İmmünfloresanda kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erişkin nefrotik sendromunda glomerüler bazal membran kalınlaşması, subepitelyal immün kompleks birikimi, granüler IgG-C3 ve spike görünümü membranöz nefropatiyi düşündürür. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.”, “Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.” ve “İmmünfloresanda kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Membranöz nefropati en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada nefrotik düzeyde proteinüri ve ödem vardır.

Kanıt 2: Biyopside glomerüler bazal membran kalınlaşması ve spike görünümü izlenmiştir.

Kanıt 3: İmmünfloresanda kapiller duvar boyunca granüler IgG ve C3 birikimi vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Membranöz nefropatide subepitelyal immün kompleks birikimi ve spike-dome görünümü klasik bulgudur.
Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 350: v195-new-350-anormal-servikal-tarama-sonucu

Başlık: Anormal servikal tarama sonucu

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: HPV ilişkili servikal intraepitelyal lezyonda koilositozu tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, servikal tarama testinde anormal hücresel değişiklik saptanması nedeniyle başvuruyor. Düzenli tarama yaptırmadığı ve sigara kullandığı öğreniliyor. Şikâyeti yoktur; temas kanaması tariflememektedir.

Demografi: 33 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Spekulum muayenesinde belirgin kitle görülmez.
- Serviks hafif eritemlidir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Servikal sitoloji

Etiket: Servikal sitoloji | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Perinükleer halo ve düzensiz hiperkromatik çekirdek içeren skuamöz hücreler izlendi. | Klinik anlam: Koilositik değişikliği destekler. | Sonuç yorumu: Koilositik değişikliği destekler. | Sonuç başlığı: Servikal sitoloji | Sonuç özeti: Perinükleer halo ve düzensiz hiperkromatik çekirdek içeren skuamöz hücreler izlendi. | Yorum: Koilositik değişikliği destekler. | Satırlar: Servikal sitoloji / Perinükleer halo ve düzensiz hiperkromatik çekirdek içeren skuamöz hücreler izlendi. // Koilositik değişikliği destekler.

Tetkik 2: HPV DNA testi

Etiket: HPV DNA testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek riskli HPV pozitif saptandı. | Klinik anlam: Servikal displazi riskini artırır. | Sonuç yorumu: Servikal displazi riskini artırır. | Sonuç başlığı: HPV DNA testi | Sonuç özeti: Yüksek riskli HPV pozitif saptandı. | Yorum: Servikal displazi riskini artırır. | Satırlar: HPV DNA testi / Yüksek riskli HPV pozitif saptandı. // Servikal displazi riskini artırır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-180 | Başlık: Servikal sitoloji | Modalite: microscopy | Bulgu: Perinükleer halo ve düzensiz hiperkromatik çekirdek içeren skuamöz hücreler izlendi. | Klinik anlam: Koilositik değişikliği destekler. | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/180_koilositoz_servikal_sitoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/180_koilositoz_servikal_sitoloji.webp | Alt text: Servikal sitoloji - Perinükleer halo ve düzensiz hiperkromatik çekirdek içeren skuamöz hücreler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu sitolojik hücresel değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Koilositoz
B) Reed-Sternberg hücresi
C) Psammoma cisimciği
D) Auer çubuğu
E) Heinz cisimciği

Doğru Cevap: Koilositoz

- A) Koilositoz: Koilositoz HPV ilişkili skuamöz hücrelerde perinükleer halo ve nükleer atipiyle tanımlanan değişikliktir. Vakadaki "Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür." ve "Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Reed-Sternberg hücresi: Reed-Sternberg hücresi lenfoid neoplazilerde görülen büyük çift çekirdekli hücredir; servikal HPV sitolojisi değildir. Bu olguda "Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür." ve "Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Koilositoz seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Psammoma cisimciği: Vakadaki Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür ve Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır. Bu olguda "Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür." ve "Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Koilositoz seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Auer çubuğu: Auer çubuğu miyeloid blastlarda görülen azurofilik çubuktur; servikal skuamöz epitel değişikliği değildir. Bu olguda "Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür." ve "Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Koilositoz seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Heinz cisimciği: Heinz cisimciği eritrosit içinde okside hemoglobin birikimidir; servikal sitolojideki koilosit değildir. Bu olguda "Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür." ve "Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır." ipuçları klinik karar açısından Koilositoz seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Anormal servikal tarama sonucu olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür." ve "Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır." birlikte okunduğunda Koilositoz seçeneği öne çıkar; "Yüksek riskli HPV testi pozitifdir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: HPV enfeksiyonunda skuamöz epitel hücrelerinde perinükleer halo ve nükleer atipi koilositoz olarak adlandırılır. Bu bulgu servikal intraepitelyal lezyonların sitolojik değerlendirmesinde önemlidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür.", "Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır." ve "Yüksek riskli HPV testi pozitifdir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Koilositoz en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Servikal sitolojide perinükleer halo içeren skuamöz hücreler görülmüştür.

Kanıt 2: Çekirdeklerde düzensizlik ve hiperkromazi tanımlanmıştır.

Kanıt 3: Yüksek riskli HPV testi pozitifdir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Koilositoz HPV etkisini gösteren perinükleer halo ve nükleer atipi bulgusudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 351: v195-new-351-postmenopozal-kanama-ve-over-kitlesi

Başlık: Postmenopozal kanama ve over kitlesi

Branş: medical-pathology | İlgili Branş: Tıbbi Patoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Patolojik bulguyu klinik bağlamla ilişkilendirme.

Learning Target: Granüloza hücreli tümörü östrojen üretimi ve Call-Exner cisimcikleriyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, postmenopozal vajinal kanama ve overde kitle nedeniyle başvuruyor. Menopozdan 9 yıl sonra yeniden kanama başladığını belirtmektedir. Karın alt kısmında dolgunluk hissi vardır.

Demografi: 61 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Pelvik muayenede sol adneksiyel bölgede mobil kitle palpe edilir.
- Uterus hafif büyümüş izlenir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol overde solid-kistik kitle ve endometriumda kalınlaşma izlendi. | Klinik anlam: Hormon üreten over tümörü olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Hormon üreten over tümörü olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sol overde solid-kistik kitle ve endometriumda kalınlaşma izlendi. | Yorum: Hormon üreten over tümörü olasılığını destekler. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / Sol overde solid-kistik kitle ve endometriumda kalınlaşma izlendi. // Hormon üreten over tümörü olasılığını destekler.

Tetkik 2: Tümör histopatolojisi

Etiket: Tümör histopatolojisi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Çekirdekleri kahve çekirdeği görünümünde hücreler ve Call-Exner cisimcikleri izlendi. | Klinik anlam: Granüloza hücreli tümör lehinedir. | Sonuç yorumu: Granüloza hücreli tümör lehinedir. | Sonuç başlığı: Tümör histopatolojisi | Sonuç özeti: Çekirdekleri kahve çekirdeği görünümünde hücreler ve Call-Exner cisimcikleri izlendi. | Yorum: Granüloza hücreli tümör lehinedir. | Satırlar: Tümör histopatolojisi / Çekirdekleri kahve çekirdeği görünümünde hücreler ve Call-Exner cisimcikleri izlendi. // Granüloza hücreli tümör lehinedir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-181 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sol overde solid-kistik kitle ve endometriumda kalınlaşma izlendi. | Klinik anlam: Hormon üreten over tümörü olasılığını destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/181_granuloza_hucrelili_tumor_over_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/181_granuloza_hucrelili_tumor_over_usg.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Sol overde solid-kistik kitle ve endometriumda kalınlaşma izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Granüloza hücreli tümör
B) Disgerminom
C) Mature kistik teratom
D) Sertoli-Leydig hücreli tümör
E) Krukenberg tümörü

Doğru Cevap: Granüloza hücreli tümör

A) Granüloza hücreli tümör: Granüloza hücreli tümör östrojen etkisi, postmenopozal kanama ve Call-Exner cisimcikleriyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.” ve “Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Disgerminom: Disgerminom germ hücreli tümördür ve genellikle genç hastalarda görülür; östrojenik endometrial kalınlaşma tipik değildir. Bu olguda “Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.” ve “Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Granüloza hücreli tümör seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Mature kistik teratom: Mature kistik teratom farklı germ tabakalarına ait dokular içerir; Call-Exner cisimcikleri beklenmez. Bu olguda “Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.” ve “Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Granüloza hücreli tümör seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Sertoli-Leydig hücreli tümör: Sertoli-Leydig hücreli tümör daha çok androjenik bulgularla ilişkilidir; östrojenik kanama paternini daha az açıklar. Bu olguda “Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.” ve “Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Granüloza hücreli tümör seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Krukenberg tümörü: Krukenberg tümörü genellikle gastrointestinal kaynaklı metastatik taşlı yüzük hücreli tümördür; Call-Exner paternine uymaz. Bu olguda “Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.” ve “Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Granüloza hücreli tümör seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Postmenopozal kanama ve over kitlesi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.” ve “Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Granüloza hücreli tümör seçeneği öne çıkar; “Histolojide Call-Exner cisimcikleri tanımlanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Postmenopozal kanama, endometrial kalınlaşma ve östrojen üretebilen over stromal tümörü granüloza hücreli tümörü düşündürür. Histolojide Call-Exner cisimcikleri ve kahve çekirdeği çekirdekler karakteristiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.”, “Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.” ve “Histolojide Call-Exner cisimcikleri tanımlanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Granüloza hücreli tümör en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada postmenopozal vajinal kanama vardır.

Kanıt 2: Endometriumda kalınlaşma ve over kitlesi saptanmıştır.

Kanıt 3: Histolojide Call-Exner cisimcikleri tanımlanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Granüloza hücreli tümör östrojen üretebilir ve Call-Exner cisimcikleriyle tanınır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: medical-pharmacology

VAKA 352: v195-new-352-tarim-ilaci-sonrasi-salivasyon-ve-bronkore

Başlık: Tarım ilacı sonrası salivasyon ve bronkore

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Organofosfat zehirlenmesinde asetilkolinesteraz inhibisyonu ve atropin-pralidoksim tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tarım ilacı uygulaması sonrası nefes darlığı, aşırı salya ve kas seğirmeleri nedeniyle getiriliyor. Kapalı alanda insektisit uyguladığı, kısa süre sonra terleme, göz yaşarması, kusma ve solunum sıkıntısı geliştiği öğreniliyor.

Demografi: 44 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %88% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,56 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta sekresyonları bol ve bronkoreiktir.
- Pupiller miyotiktir.
- Yaygın fasikülasyonlar izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma kolinesteraz aktivitesi

Etiket: Plazma kolinesteraz aktivitesi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Asetilkolinesteraz inhibisyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Asetilkolinesteraz inhibisyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Plazma kolinesteraz aktivitesi | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Asetilkolinesteraz inhibisyonunu destekler. | Satırlar: Plazma kolinesteraz aktivitesi / Düşük saptandı. // Asetilkolinesteraz inhibisyonunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun antitotal tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Atropin ve pralidoksim uygulanması
B) N-asetilsistein verilmesi
C) Vitamin K verilmesi
D) Flumazenil verilmesi
E) Digoksin antikor fragmanı verilmesi

Doğru Cevap: Atropin ve pralidoksim uygulanması

A) Atropin ve pralidoksim uygulanması: Atropin ve pralidoksim organofosfat zehirlenmesinde muskarinik yükü ve asetilkolinesteraz inhibisyonunu hedefleyen uygun tedavidir. Vakadaki “Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.” ve “Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) N-asetilsistein verilmesi: Vakadaki Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır ve Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır. Bu olguda “Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.” ve “Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Vitamin K verilmesi: Vitamin K varfarin etkisini geri çevirmek için kullanılır; asetilkolinesteraz inhibisyonunu düzeltmez. Bu olguda “Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.” ve “Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Flumazenil verilmesi: Flumazenil benzodiazepin antagonisti olarak kullanılır; insektisit ilişkili kolinerjik tabloyu tedavi etmez. Bu olguda “Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.” ve “Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Digoksin antikor fragmanı verilmesi: Digoksin antikor fragmanı digoksin toksisitesinde kullanılır; organofosfat zehirlenmesi için uygun değildir. Bu olguda “Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.” ve “Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Atropin ve pralidoksim uygulanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tarım ilacı sonrası salivasyon ve bronkore olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.” ve “Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.” birlikte okunduğunda Atropin ve pralidoksim uygulanması seçeneği öne çıkar; “Fasikülasyonlar nikotinik etkilenimi göstermektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Organofosfatlar asetilkolinesterazı inhibe ederek muskarinik, nikotinik ve santral kolinerjik bulgular oluşturur. Atropin muskarinik bulguları kontrol eder; pralidoksim erken dönemde enzim reaktivasyonuna yardımcı olur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.”, “Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.” ve “Fasikülasyonlar nikotinik etkilenimi göstermektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Atropin ve pralidoksim uygulanması en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakınmalar insektisit maruziyeti sonrası başlamıştır.

Kanıt 2: Miyozis, bronkore ve aşırı sekresyon vardır.

Kanıt 3: Fasikülasyonlar nikotinik etkilenimi göstermektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Organofosfat zehirlenmesinde atropin muskarinik bulgulara, pralidoksim enzim reaktivasyonuna yöneliktir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 353: v195-new-353-ldl-yuksekligi-icin-baslanan-ilac

Başlık: LDL yüksekliği için başlanan ilaç

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Kolay

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Statinlerin HMG-CoA redüktaz inhibisyonu ile LDL düşürücü etkisini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yüksek LDL kolesterol nedeniyle başlanan ilacın etki mekanizmasını öğrenmek istemektedir. Hipertansiyon ve sigara öyküsü vardır. Kardiyovasküler risk değerlendirmesi sonrası statin tedavisi planlanmıştır.

Demografi: 56 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 132/80 mmHg | Nabız: 76/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,58

Fizik Muayene

- Fizik muayenede akut patoloji yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: LDL kolesterol

Etiket: LDL kolesterol | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: LDL düşürücü tedavi gereksinimini destekler. | Sonuç yorumu: LDL düşürücü tedavi gereksinimini destekler. | Sonuç başlığı: LDL kolesterol | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: LDL düşürücü tedavi gereksinimini destekler. | Satırlar: LDL kolesterol / 178 mg/dL / <100 mg/dL hedef risk durumuna göre değişir / LDL düşürücü tedavi gereksinimini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Statinlerin LDL kolesterolü düşüren temel mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) HMG-CoA redüktaz inhibisyonu
B) P2Y₁₂ reseptör blokajı
C) Beta-2 reseptör aktivasyonu
D) Dihidropteroat sentaz inhibisyonu
E) H/K ATPaz inhibisyonu

Doğru Cevap: HMG-CoA redüktaz inhibisyonu

A) HMG-CoA redüktaz inhibisyonu: HMG-CoA redüktaz inhibisyonu statinlerin kolesterol sentezini azaltan ve LDL reseptörlerini artıran temel mekanizmasıdır. Vakadaki "Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır." ve "Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) P2Y₁₂ reseptör blokajı: Vakadaki Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır ve Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır. Bu olguda "Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır." ve "Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Beta-2 reseptör aktivasyonu: Beta-2 reseptör aktivasyonu bronkodilatasyon ve metabolik etkilerle ilişkilidir; statin mekanizması değildir. Bu olguda "Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır." ve "Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Dihidropteroat sentaz inhibisyonu: Dihidropteroat sentaz inhibisyonu sülfonamidlere aittir; kolesterol senteziyle ilişkili değildir. Bu olguda "Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır." ve "Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.
E) H/K ATPaz inhibisyonu: Vakadaki Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır ve Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır. Bu olguda "Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır." ve "Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır." ipuçları mekanizma bilgisi açısından HMG-CoA redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: LDL yüksekliği için başlanan ilaç olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. "Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır." ve "Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır." birlikte okunduğunda HMG-CoA redüktaz inhibisyonu seçeneği öne çıkar; "Soru LDL düşürücü mekanizmayı sorgulamaktadır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Statinler kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı basamağı olan HMG-CoA redüktazı inhibe eder. Hepatik kolesterol azalınca LDL reseptör ekspresyonu artar ve plazmadaki LDL temizlenmesi yükselir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır.", "Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır." ve "Soru LDL düşürücü mekanizmayı sorgulamaktadır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle HMG-CoA redüktaz inhibisyonu en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Hastada LDL kolesterol yüksekliği vardır.

Kanıt 2: Kardiyovasküler risk nedeniyle statin planlanmıştır.

Kanıt 3: Soru LDL düşürücü mekanizmayı sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Statinler HMG-CoA redüktazı inhibe eder ve karaciğerde LDL reseptörlerini artırır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 354: v195-new-354-kemoterapi-sonrasi-mukozit

Başlık: Kemoterapi sonrası mukozit

Branş: medical-pharmacology | İlgili Branş: Tıbbi Farmakoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Mekanizmayı klinik bulgularla ilişkilendirme.

Learning Target: Metotreksatın dihidrofolat redüktaz inhibisyonunu ve folinik asit kurtarma mantığını açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, metotreksat içeren tedavi sonrası mukozit ve kemik iliği baskılanması açısından izleniyor. Yüksek doz metotreksat protokolü aldığı ve tedavi sonrası kurtarma tedavisi planlandığı öğreniliyor. Böbrek fonksiyonu yakından izlenmektedir.

Demografi: 47 yaşında kadın hasta | Setting: Servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/72 mmHg | Nabız: 90/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 0,76

Fizik Muayene

- Oral mukozada eritem ve hassasiyet vardır.
- Ateşi yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lökosit sayısında düşme eğilimi saptandı. | Klinik anlam: Antimetabolit toksisitesini destekleyebilir. | Sonuç yorumu: Antimetabolit toksisitesini destekleyebilir. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lökosit sayısında düşme eğilimi saptandı. | Yorum: Antimetabolit toksisitesini destekleyebilir. | Satırlar: Tam kan sayımı / Lökosit sayısında düşme eğilimi saptandı. // Antimetabolit toksisitesini destekleyebilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Metotreksatın temel antimetabolit etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu
- B) Topoisomerez II stabilizasyonu
- C) Mikrotübül polimerizasyonunun kalıcı artırılması
- D) HMG-CoA redüktaz inhibisyonu
- E) Na/K ATPaz inhibisyonu

Doğru Cevap: Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu

A) Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu: Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu metotreksatın folat metabolizmasını bozarak DNA sentezini azaltan temel mekanizmasıdır. Vakadaki “Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.” ve “Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Topoisomerez II stabilizasyonu: Topoisomerez II stabilizasyonu etoposid gibi ilaçların mekanizmasıyla ilişkilidir; metotreksat için uygun değildir. Bu olguda “Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.” ve “Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Mikrotübül polimerizasyonunun kalıcı artırılması: Mikrotübül polimerizasyonunun artırılması taksanlarla ilişkilidir; metotreksatın antimetabolit etkisini açıklamaz. Bu olguda “Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.” ve “Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) HMG-CoA redüktaz inhibisyonu: Vakadaki Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır ve Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler. Bu olguda “Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.” ve “Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Na/K ATPaz inhibisyonu: Vakadaki Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır ve Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler. Bu olguda “Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.” ve “Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.” ipuçları mekanizma bilgisi açısından Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kemoterapi sonrası mukozit olgusunda klinik karar mekanizma bilgisi üzerine kuruludur. “Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.” ve “Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.” birlikte okunduğunda Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu seçeneği öne çıkar; “Soru antimetabolit etki mekanizmasını sorgulamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Metotreksat dihidrofolat redüktazı inhibe ederek tetrahidrofolat yenilenmesini azaltır. Böylece timidilat ve pürin sentezi bozulur; hızlı bölünen hücrelerde etki ve toksisite gelişir. Folinik asit kurtarma normal hücrelerde folat havuzunu desteklemek için kullanılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.”, “Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.” ve “Soru antimetabolit etki mekanizmasını sorgulamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Dihidrofolat redüktaz inhibisyonu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta metotreksat içeren yüksek doz protokol almaktadır.

Kanıt 2: Mukozit ve lökosit düşüşü hızlı bölünen hücre toksisitesini destekler.

Kanıt 3: Soru antimetabolit etki mekanizmasını sorgulamaktadır.

Core Knowledge: Mekanizma sorularında klinik bulgu, laboratuvar paterni ve biriken/eksilen metabolit aynı biyokimyasal basamağa bağlanmalıdır. Benzer fenotipler, etkilenen enzim, yolak veya kalıtım paterni farklı olduğunda ayrılır.

Exam Pearl: Metotreksat DHFR inhibitörüdür; yüksek doz kullanımda folinik asit kurtarma toksisiteyi azaltmak için verilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: general-surgery

VAKA 355: v195-new-355-kusma-sonrasi-gogus-agrisi

Başlık: Kusma sonrası göğüs ağrısı

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Boerhaave sendromunda şiddetli kusma sonrası özofagus perforasyonunu tanıyıp acil yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, şiddetli kusmayı takiben gelişen göğüs ağrısı ve nefes darlığı nedeniyle başvuruyor. Ağır yemek ve alkol alımı sonrası birkaç kez güçlü kusma olduğu, ardından ani başlayan retrosternal ağrı ve sol omuza yayılan rahatsızlık geliştiği öğreniliyor.

Demografi: 52 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.1°C | Şok indeksi: 1,03 (yüksek)

Fizik Muayene

- Hasta toksik görünümündedir.
- Sol hemitoraksta solunum sesleri azalmıştır.
- Boyunda hafif cilt altı krepitasyon vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Toraks BT

Etiket: Toraks BT | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı, mediastinal sıvı ve sol plevral efüzyon izlendi. | Klinik anlam: Özofagus perforasyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Özofagus perforasyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Toraks BT | Sonuç özeti: Distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı, mediastinal sıvı

ve sol plevral efüzyon izlendi. | Yorum: Özofagus perforasyonunu destekler. | Satırlar: Toraks BT / Distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı, mediastinal sıvı ve sol plevral efüzyon izlendi. // Özofagus perforasyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-182 | Başlık: Toraks BT | Modalite: ct | Bulgu: Distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı, mediastinal sıvı ve sol plevral efüzyon izlendi. | Klinik anlam: Özofagus perforasyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/182_ozofagus_perforasyonu_toraks_bt.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/182_ozofagus_perforasyonu_toraks_bt.webp | Alt text: Toraks BT - Distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı, mediastinal sıvı ve sol plevral efüzyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek
B) Oral antiasit tedavisiyle ayaktan izlem planlamak
C) Zorlayıcı oral beslenme başlamak
D) Elektif psikiyatri kontrolü planlamak
E) İnhaler bronkodilatör vermek

Doğru Cevap: Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek

A) Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek: Ağızdan alımı kesmek, antibiyotik başlamak ve acil onarım değerlendirmek özofagus perforasyonunda doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.” ve “Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Oral antiasit tedavisiyle ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır ve Boyunda cilt altı krepitasyon vardır. Bu olguda “Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.” ve “Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Zorlayıcı oral beslenme başlamak: Vakadaki Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır ve Boyunda cilt altı krepitasyon vardır. Bu olguda “Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.” ve “Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Elektif psikiyatri kontrolü planlamak: Vakadaki Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır ve Boyunda cilt altı krepitasyon vardır. Bu olguda “Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.” ve “Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.
E) İnhaler bronkodilatör vermek: Vakadaki Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır ve Boyunda cilt altı krepitasyon vardır. Bu olguda “Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.” ve “Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kusma sonrası göğüs ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.” ve “Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.” birlikte okunduğunda Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek seçeneği öne çıkar; “BT”de distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı ve mediastinal sıvı izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Şiddetli kusma sonrası ani göğüs ağrısı, subkutan krepitasyon, plevral efüzyon ve mediastinal hava Boerhaave sendromunu düşündürür. Özofagus perforasyonu mediastinite yol açabileceği için ağızdan alım kesilmeli, antibiyotik başlanmalı ve acil onarım değerlendirilmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.”, “Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.” ve “BT”de distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı ve mediastinal sıvı izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ağızdan alımı kesmek, geniş spektrumlu antibiyotik başlamak ve acil cerrahi/endoskopik onarım değerlendirmek en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Ağrı güçlü kusma ataklarından sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Boyunda cilt altı krepitasyon vardır.

Kanıt 3: BT’de distal özofagus komşuluğunda hava kaçağı ve mediastinal sıvı izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığına seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk başamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Kusma sonrası özofagus perforasyonu cerrahi acildir ve mediastinit riski taşır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 356: v195-new-356-kasik-altinda-agrili-sislik

Başlık: Kasık altında ağrılı şişlik

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Femoral hernide kasık altı ağrılı kitle ve strangülasyon riskini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sağ kasık altında ağrılı şişlik ve bulantı nedeniyle başvuruyor. Şişliğin daha önce ayakta belirginleşip yatınca azaldığı, bugün ise sertleştiği ve içeri itilemediği öğreniliyor. Kusma ve karın şişliği başlamıştır.

Demografi: 69 yaşında kadın hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/74 mmHg | Nabız: 106/dk | Solunum: 16/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,90

Fizik Muayene

- Sağ inguinal ligamentin altında, pubik tüberkülün lateral-inferiorunda hassas ve redükte edilemeyen kitle palpe edilir.
- Batın hafif distandüdü.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kasık ultrasonografisi

Etiket: Kasık ultrasonografisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. | Klinik anlam: Femoral herniyi destekler. | Sonuç yorumu: Femoral herniyi destekler. | Sonuç başlığı: Kasık ultrasonografisi | Sonuç özeti: Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. | Yorum: Femoral herniyi destekler. | Satırlar: Kasık ultrasonografisi / Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. // Femoral herniyi destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-183 | Başlık: Kasık ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi izlendi. | Klinik anlam: Femoral herniyi destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/183_femoral_herni_kasik_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/183_femoral_herni_kasik_usg.webp | Alt text: Kasık ultrasonografisi - Femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnkarsere femoral herni
B) Varikosel
C) Hidrosel
D) Epididimit
E) Lenfödem

Doğru Cevap: İnkarsere femoral herni

A) İnkarsere femoral herni: İnkarsere femoral herni inguinal ligament altında redükte edilemeyen ağrılı kitle ve barsak ansı içeren kese ile en uyumludur. Vakadaki “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Varikosel: Varikosel skrotal venöz genişleme yapar ve ayakta solucan torbası hissiyle tariflenir; femoral kanal kitlesi değildir. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.” ipuçları tanısız karar açısından İnkarsere femoral herni seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Hidrosel: Hidrosel skrotal sıvı birikimidir; kasık altında barsak ansı içeren redükte edilemeyen kitle yapmaz. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.” ipuçları tanısız karar açısından İnkarsere femoral herni seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Epididimit: Vakadaki Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir ve Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.” ipuçları tanısız karar açısından İnkarsere femoral herni seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Lenfödem: Lenfödem yaygın ekstremitte şişliği yapar; lokal redükte edilemeyen barsak içerikli kitle değildir. Bu olguda “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.” ipuçları tanısız karar açısından İnkarsere femoral herni seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kasık altında ağrılı şişlik olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.” ve “Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.” birlikte okunduğunda İnkarsere femoral herni seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi görülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yaşlı kadın hastada inguinal ligament altında, femoral kanal düzeyinde redükte edilemeyen ağrılı kitle femoral herniyi düşündürür. Femoral herniler dar boyun nedeniyle strangüstasyon açısından yüksek risk taşır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.”, “Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.” ve “Ultrasonografide femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi görülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İnkarsere femoral herni en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Kitle inguinal ligamentin altında yerleşmiştir.

Kanıt 2: Şişlik hassas ve redükte edilemez durumdadır.

Kanıt 3: Ultrasonografide femoral kanal düzeyinde barsak ansı içeren herni kesesi görülmüştür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Femoral herni kadınlarda daha sık görülür ve strangüstasyon riski yüksektir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 357: v195-new-357-erken-evre-meme-kitlesi

Başlık: Erken evre meme kitlesi

Branş: general-surgery | İlgili Branş: Genel Cerrahi | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Uygun tanısız testi klinik bağlamla seçme.

Learning Target: Meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisinin aksiller evrelemedeki yerini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, tarama mamografisinde saptanan küçük meme kitlesi nedeniyle başvuruyor. Ailesinde meme kanseri öyküsü yoktur. Kitle elle zor seçilmektedir. Koltuk altında ele gelen belirgin lenf nodu tariflememektedir.

Demografi: 48 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sol meme üst dış kadranda yaklaşık 1.2 cm sertlik palpe edilir.
- Aksillada klinik olarak belirgin lenf nodu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kor biyopsi

Etiket: Kor biyopsi | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: İnvaziv duktal karsinom saptandı. | Klinik anlam: Meme malignitesini doğrular. | Sonuç yorumu: Meme malignitesini doğrular. | Sonuç başlığı: Kor biyopsi | Sonuç özeti: İnvaziv duktal karsinom saptandı. | Yorum: Meme malignitesini doğrular. | Satırlar: Kor biyopsi / İnvaziv duktal karsinom saptandı. // Meme malignitesini doğrular.

Tetkik 2: Aksiller ultrasonografi

Etiket: Aksiller ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. | Klinik anlam: Klinik olarak nod negatif aksillayı destekler. | Sonuç yorumu: Klinik olarak nod negatif aksillayı destekler. | Sonuç başlığı: Aksiller ultrasonografi | Sonuç özeti: Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. | Yorum: Klinik olarak nod negatif aksillayı destekler. | Satırlar: Aksiller ultrasonografi / Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. // Klinik olarak nod negatif aksillayı destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-184 | Başlık: Kor biyopsi | Modalite: microscopy | Bulgu: İnvaziv duktal karsinom saptandı. | Klinik anlam: Meme malignitesini doğrular. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/184_in vaziv_duktal_karsinom_histopatoloji.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/184_in vaziv_duktal_karsinom_histopatoloji.webp | Alt text: Kor biyopsi - İnvaziv duktal karsinom saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Görsel 2: ID: visual-185 | Başlık: Aksiller ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. | Klinik anlam: Klinik olarak nod negatif aksillayı destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/185_aksiller_lenf_nodu_ultrasonografi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/185_aksiller_lenf_nodu_ultrasonografi.webp | Alt text: Aksiller ultrasonografi - Patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Klinik olarak nod negatif bu hastada aksiller evreleme için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sentinel lenf nodu biyopsisi
B) Rutin tüm aksiller lenf nodlarının çıkarılması

- C) Aksillaya ileri değerlendirme yapmamak
D) Serum tümör belirteciyle evrelemek
E) Mide endoskopisi yapmak

Doğru Cevap: Sentinel lenf nodu biyopsisi

A) Sentinel lenf nodu biyopsisi: Sentinel lenf nodu biyopsisi klinik nod negatif erken meme kanserinde aksiller evreleme için uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.” ve “Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Rutin tüm aksiller lenf nodlarının çıkarılması: Rutin tüm aksiller lenf nodlarının çıkarılması nod negatif hastada gereksiz morbiditeye neden olabilir. Bu olguda “Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.” ve “Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sentinel lenf nodu biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Aksillaya ileri değerlendirme yapmamak: Aksillaya ileri değerlendirme yapmamak bu Vakadaki tanısal hedefi yeterince karşılamaz; vaka bağlamında Sentinel lenf nodu biyopsisi daha uygun ve hedefe yönelik tanısal basamaktır. Bu olguda “Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.” ve “Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sentinel lenf nodu biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Serum tümör belirteciyle evrelemek: Serum tümör belirteciyle evrelemek bu olguda tanısal kararın ana sorusunu yanıtlamaz; mevcut klinik bağlamda Sentinel lenf nodu biyopsisi hedeflenen tanısal basamağı daha doğrudan karşılar. Bu olguda “Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.” ve “Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sentinel lenf nodu biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Mide endoskopisi yapmak: Vakadaki Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır ve Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur. Bu olguda “Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.” ve “Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Sentinel lenf nodu biyopsisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken evre meme kitlesi olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.” ve “Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.” birlikte okunduğunda Sentinel lenf nodu biyopsisi seçeneği öne çıkar; “Tümör küçük ve erken evre bağlamındadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erken evre ve klinik nod negatif meme kanserinde aksiller evreleme için sentinel lenf nodu biyopsisi tercih edilir. Böylece gereksiz aksiller diseksiyonun lenfödem gibi morbiditeleri azaltılabilir. Bu olguda “Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.” ve “Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.” ve “Tümör küçük ve erken evre bağlamındadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Sentinel lenf nodu biyopsisi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada invaziv meme kanseri biyopsiyle doğrulanmıştır.

Kanıt 2: Aksillada klinik ve ultrasonografik patolojik lenf nodu yoktur.

Kanıt 3: Tümör küçük ve erken evre bağlamındadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Klinik nod negatif erken meme kanserinde sentinel lenf nodu biyopsisi aksiller evreleme için standart yaklaşımdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: obstetrics-gynecology

VAKA 358: v195-new-358-alt-karin-agrisi-ve-servikal-hassasiyet

Başlık: Alt karın ağrısı ve servikal hassasiyet

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Pelvik inflamatuvar hastalıkta servikal hareket hassasiyeti ve mukopürülan akıntıyla ampirik tedaviyi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, alt karın ağrısı, ateş ve vajinal akıntı nedeniyle başvuruyor. Son haftalarda yeni cinsel partneri olduğu, kondom kullanmadığı ve ilişki sonrası ağrısının arttığı öğreniliyor. Gebelik testi evde negatif çıkmıştır.

Demografi: 24 yaşında kadın hasta | Setting: Doğum acil ünitesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 112/70 mmHg | Nabız: 108/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 38.2°C | Şok indeksi: 0,96 (sınırdan yüksek)

Fizik Muayene

- Alt batında bilateral hassasiyet vardır.
- Spekulum muayenesinde mukopürülan servikal akıntı izlenir.
- Bimanuel muayenede servikal hareket hassasiyeti belirgindir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum beta-hCG

Etiket: Serum beta-hCG | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Negatif saptandı. | Klinik anlam: Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter. | Sonuç yorumu: Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter. | Sonuç başlığı: Serum beta-hCG | Sonuç özeti: Negatif saptandı. | Yorum: Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter. | Satırlar: Serum beta-hCG / Negatif saptandı. // Gebelik ilişkili acilleri geri plana iter.

Tetkik 2: Servikal NAAT

Etiket: Servikal NAAT | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae için örnek alındı; sonuç bekleniyor. | Klinik anlam: Etken araştırması yapılmıştır ancak tedaviyi geciktirmemelidir. | Sonuç yorumu: Etken araştırması yapılmıştır ancak tedaviyi geciktirmemelidir. | Sonuç başlığı: Servikal NAAT | Sonuç özeti: Chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae için örnek alındı; sonuç bekleniyor. | Yorum: Etken araştırması yapılmıştır ancak tedaviyi geciktirmemelidir. | Satırlar: Servikal NAAT / Chlamydia trachomatis ve Neisseria gonorrhoeae için örnek alındı; sonuç bekleniyor. // Etken araştırması yapılmıştır ancak tedaviyi geciktirmemelidir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak
B) Mikrobiyolojik sonuçlara göre tedaviyi planlayarak klinik izlem yapmak
C) Topikal antifungal tedaviyle ayaktan izlem planlamak
D) Acil rahim alınması yapmak
E) Ağrı kesici vererek ayaktan izlem planlamak

Doğru Cevap: Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak

A) Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak: Ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi PID şüphesinde infertilite ve kronik pelvik ağrı riskini azaltmak için uygundur. Vakadaki "Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır." ve "Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Mikrobiyolojik sonuçlara göre tedaviyi planlayarak klinik izlem yapmak: Vakadaki Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır ve Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır." ve "Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Topikal antifungal tedaviyle ayakta izlem planlamak: Vakadaki Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır ve Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır." ve "Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Acil rahim alınması yapmak: Vakadaki Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır ve Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır." ve "Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ağrı kesici vererek ayakta izlem planlamak: Vakadaki Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır ve Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır. Bu olguda "Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır." ve "Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekeç / Kanıt / Core

Klinik gerekeç: Alt karın ağrısı ve servikal hassasiyet olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır." ve "Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır." birlikte okunduğunda Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak seçeneği öne çıkar; "Ateş ve bilateral alt karın hassasiyeti eşlik etmektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Alt karın ağrısı, ateş, mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti pelvik inflamatuvar hastalığı düşündürür. Üreme sağlığı komplikasyonlarını önlemek için test sonuçları beklenmeden uygun ampirik antibiyotik başlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır.", "Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır." ve "Ateş ve bilateral alt karın hassasiyeti eşlik etmektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Pelvik inflamatuvar hastalık için ampirik geniş kapsamlı antibiyotik tedavisi başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hastada yeni cinsel partner ve korunmasız ilişki öyküsü vardır.

Kanıt 2: Mukopürülen servikal akıntı ve servikal hareket hassasiyeti saptanmıştır.

Kanıt 3: Ateş ve bilateral alt karın hassasiyeti eşlik etmektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: PID şüphesinde tedavi mikrobiyolojik sonuçlar beklenmeden ampirik başlanır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 359: v195-new-359-menopoz-sonrasi-vajinal-kanama

Başlık: Menopoz sonrası vajinal kanama

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Uygun tanısal testi klinik bağlamla seçme.

Learning Target: Postmenopozal kanamada endometrial örnekleme gerekliliğini endometrium kalınlığıyla ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, menopozdan yıllar sonra başlayan vajinal kanama nedeniyle başvuruyor. Menopoza 11 yıl önce girdiği, son bir ayda iki kez lekelenme şeklinde kanaması olduğu öğreniliyor. Obezite ve hipertansiyon öyküsü vardır.

Demografi: 63 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 142/84 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,86

Fizik Muayene

- Pelvik muayenede aktif yoğun kanama yoktur.
- Servikte belirgin polipoid lezyon görülmez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Klinik anlam: Endometrial patoloji açısından değerlendirme gerektirir. | Sonuç yorumu: Endometrial patoloji açısından değerlendirme gerektirir. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Yorum: Endometrial patoloji açısından değerlendirme gerektirir. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / 9 mm / Postmenopozal kanamada genellikle ≤4 mm düşük riskli kabul edilir / Endometrial patoloji açısından değerlendirme gerektirir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-186 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Klinik anlam: Endometrial patoloji açısından değerlendirme gerektirir. | URL: https://iukbtlkzxicqdsd.public.blob.vercel-storage.com/186_postmenopozal_endometrium_kalinlasmasi_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxicqdsd.public.blob.vercel-storage.com/186_postmenopozal_endometrium_kalinlasmasi_usg.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Endometrium kalınlığı artmış saptandı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun sonraki tanısal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Endometrial biyopsi yapılması
- B) Yıllık kontrol önerilmesi
- C) Ovulasyon indüksiyonu başlanması
- D) Gebelik testi pozitif kabul edilerek takip
- E) Antifungal tedavi başlanması

Doğru Cevap: Endometrial biyopsi yapılması

A) Endometrial biyopsi yapılması: Endometrial biyopsi postmenopozal kanama ve artmış endometrium kalınlığında uygun sonraki tanısal yaklaşımdır. Vakadaki "Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır." ve "Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Yıllık kontrol önerilmesi: Yıllık kontrol önerilmesi, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda "Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır." ve "Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir." ipuçları tedavi önceliği açısından Endometrial biyopsi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Ovulasyon indüksiyonu başlanması: Ovulasyon indüksiyonu infertilite tedavisinde kullanılır; postmenopozal kanama değerlendirmesi değildir. Bu olguda “Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır.” ve “Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endometrial biyopsi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Gebelik testi pozitif kabul edilerek takip: Menopozdan yıllar sonra gebelik varsayımı klinik olarak uygun değildir ve kanama nedenini açıklamaz. Bu olguda “Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır.” ve “Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endometrial biyopsi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Antifungal tedavi başlanması: Antifungal tedavi kaşıntılı akıntı tablolarında düşünülebilir; endometrial kalınlaşmayı değerlendirmez. Bu olguda “Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır.” ve “Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Endometrial biyopsi yapılması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Menopoz sonrası vajinal kanama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır.” ve “Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir.” birlikte okunduğunda Endometrial biyopsi yapılması seçeneği öne çıkar; “Obezite ve hipertansiyon endometrial neoplazi riskini artırmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Postmenopozal kanama endometrium kanseri dışlanana kadar patolojik kabul edilir. Endometrium kalınlığının artmış olması ve obezite-hipertansiyon gibi riskler endometrial örnekleme gerekliliği. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır.”, “Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir.” ve “Obezite ve hipertansiyon endometrial neoplazi riskini artırmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Endometrial biyopsi yapılması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kanama menopozdan yıllar sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Endometrium kalınlığı postmenopozal kanama için artmış düzeydedir.

Kanıt 3: Obezite ve hipertansiyon endometrial neoplazi riskini artırmaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Postmenopozal kanamada artmış endometrium kalınlığı varsa endometrial biyopsi gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 360: v195-new-360-yogun-adet-kanamasi-ve-pelvik-basi

Başlık: Yoğun adet kanaması ve pelvik bası

Branş: obstetrics-gynecology | İlgili Branş: Kadın Hastalıkları ve Doğum | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Uterin leiomyomu menoraji ve iyi sınırlı myometrial kitleyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, yoğun adet kanaması ve pelvik bası hissi nedeniyle başvuruyor. Son bir yıldır adetlerinin daha uzun ve pıhtılı geçtiğini, sık idrara çıkma ve alt karında dolgunluk hissettiğini belirtmektedir. Gebelik düşünmemektedir.

Demografi: 39 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Uterus bimanuel muayenede düzensiz büyümüş ve mobil palpe edilir.
- Servikal hareket hassasiyeti yoktur.
- Ateş saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Transvajinal ultrasonografi

Etiket: Transvajinal ultrasonografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Myometrium içinde iyi sınırlı, hipoeoik solid kitleler izlendi. | Klinik anlam: Leiomyom ile uyumludur. | Sonuç yorumu: Leiomyom ile uyumludur. | Sonuç başlığı: Transvajinal ultrasonografi | Sonuç özeti: Myometrium içinde iyi sınırlı, hipoeoik solid kitleler izlendi. | Yorum: Leiomyom ile uyumludur. | Satırlar: Transvajinal ultrasonografi / Myometrium içinde iyi sınırlı, hipoeoik solid kitleler izlendi. / / Leiomyom ile uyumludur.

Tetkik 2: Hemogloblin

Etiket: Hemogloblin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hafif düşük saptandı. | Klinik anlam: Kronik kan kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Kronik kan kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Hemogloblin | Sonuç özeti: Hafif düşük saptandı. | Yorum: Kronik kan kaybını destekler. | Satırlar: Hemogloblin / 10.8 g/dL / 12-16 g/dL / Kronik kan kaybını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-187 | Başlık: Transvajinal ultrasonografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Myometrium içinde iyi sınırlı, hipoeoik solid kitleler izlendi. | Klinik anlam: Leiomyom ile uyumludur. | URL: https://iukbtikzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/187_uterin_leiomyom_transvajinal_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtikzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/187_uterin_leiomyom_transvajinal_usg.webp | Alt text: Transvajinal ultrasonografi - Myometrium içinde iyi sınırlı, hipoeoik solid kitleler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uterin leiomyom
- B) Pelvik inflamatuvar hastalık
- C) Vajinal kandidiyazis
- D) Bartholin apsesi
- E) Gestasyonel trofoblastik hastalık

Doğru Cevap: Uterin leiomyom

A) Uterin leiomyom: Uterin leiomyomu menoraji, pelvik bası ve myometrial iyi sınırlı solid kitlelerle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.” ve “Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Pelvik inflamatuvar hastalık: Pelvik inflamatuvar hastalık ateş, alt karın ağrısı ve servikal hareket hassasiyetiyle seyreder; bu hastada kitle paternini açıklamaz. Bu olguda “Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.” ve “Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Uterin leiomyom seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Vajinal kandidiyazis: Vajinal kandidiyazis kaşıntı ve beyaz akıntı yapar; uterus büyümesi ve myometrial kitle oluşturmaz. Bu olguda “Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.” ve “Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Uterin leiomyom seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Bartholin apsesi: Vakadaki Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır ve Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir. Bu olguda “Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.” ve “Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Uterin leiomyom seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Gestasyonel trofoblastik hastalık: Gestasyonel trofoblastik hastalık gebelik ilişkili beta-hCG yüksekliği ve uterin trofoblastik proliferasyonla ilişkilidir; bu olguda myometrial leiomyom görünümü vardır. Bu olguda “Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.” ve “Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.” ipuçları tanısal karar açısından Uterin leiomyom seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yoğun adet kanaması ve pelvik bası olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.” ve “Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.” birlikte okunduğunda Uterin leiomyom seçeneği öne çıkar; “Ultrasonografide myometrium içinde iyi sınırlı solid kitleler izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Üreme çağındaki kadında yoğun adet kanaması, pelvik bası, düzensiz büyümüş uterus ve myometrium içinde iyi sınırlı solid kitleler uterin leiomyomu düşündürür. Kitleler benign düz kas tümörleridir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.”, “Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.” ve “Ultrasonografide myometrium içinde iyi sınırlı solid kitleler izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Uterin leiomyom en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Hastada yoğun ve uzamış adet kanaması vardır.

Kanıt 2: Uterus düzensiz büyümüş olarak palpe edilmiştir.

Kanıt 3: Ultrasonografide myometrium içinde iyi sınırlı solid kitleler izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Leiomyomlar myometrium kaynaklı benign düz kas tümörleridir ve menoraji-bası semptomları yapabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: minor-rotations

VAKA 361: v195-new-361-ani-yuz-felci

Başlık: Ani yüz felci

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısai paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Periferik fasyal paralizi alin tutulumu ve göz kapatma kaybıyla santral lezyondan ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, sabah uyandığında sağ yüz yarısında güçsüzlük fark etmesi nedeniyle başvuruyor. Bir gün önce sağ kulak arkasında hafif ağrı olduğunu, bugün ağzının sola kaydığını ve sağ gözünü kapatamadığını belirtmektedir. Kol-bacak güçsüzlüğü veya konuşma bozukluğu yoktur.

Demografi: 42 yaşında kadın hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ alın kırıştırma, göz kapatma ve ağız köşesi hareketleri zayıftır.
- Ekstremit motor muayenesi normaldir.
- Duyu muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Periferik fasyal paralizi
- B) Migren aurası
- C) Trigeminal nevralsi
- D) Esansiyel tremor
- E) Normal basınçlı hidrosefali

Doğru Cevap: Periferik fasyal paralizi

A) Periferik fasyal paralizi: Periferik fasyal paralizi ipsilateral alın, göz kapatma ve ağız köşesi güçsüzlüğüyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.” ve “Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Migren aurası: Migren aurası geçici görsel veya duyu belirtiyle seyreder; tüm yüz yarısında motor paralizi yapması tipik değildir. Bu olguda “Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.” ve “Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından Periferik fasyal paralizi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Trigeminal nevralsi: Vakadaki Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır ve Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir. Bu olguda “Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.” ve “Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından Periferik fasyal paralizi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Esansiyel tremor: Vakadaki Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır ve Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir. Bu olguda “Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.” ve “Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından Periferik fasyal paralizi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Normal basınçlı hidrosefali: Normal basınçlı hidrosefali yürüme bozukluğu, idrar kaçırma ve bilişsel etkilendirilmeyle seyreder; akut yüz felci yapmaz. Bu olguda “Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.” ve “Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.” ipuçları tanısai karar açısından Periferik fasyal paralizi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ani yüz felci olgusunda klinik karar tanısai karar üzerine kuruludur. “Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.” ve “Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.” birlikte okunduğunda Periferik fasyal paralizi seçeneği öne çıkar; “Kol-bacak güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu yoktur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yüzün üst ve alt kısmını birlikte tutan tek taraflı fasyal güçsüzlük periferik fasyal paralizi düşündürür. Santral üst motor nöron lezyonlarında alın çoğu kez korunur; bu hastada alın ve göz kapatma da etkilendirilmiştir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.”, “Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.” ve “Kol-bacak güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu yoktur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Periferik fasyal paralizi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Sağ alın kırıştırma ve göz kapatma zayıflamıştır.

Kanıt 2: Ağız köşesi hareketi aynı tarafta etkilendirilmiştir.

Kanıt 3: Kol-bacak güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu yoktur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Periferik fasiyal paralizide ipsilateral alın da tutulur; santral yüz felcinde alın genellikle korunur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 362: v195-new-362-tekrarlayan-vertigo-ve-kulakta-dolgunluk

Başlık: Tekrarlayan vertigo ve kulakta dolgunluk

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Meniere hastalığını episodik vertigo, tinnitus ve dalgalanan işitme kaybıyla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, ataklar halinde gelen baş dönmesi, kulakta çınlama ve işitmede azalma nedeniyle başvuruyor. Son altı ayda birkaç kez saatler süren dönme hissi yaşadığını, ataklar sırasında sol kulakta dolgunluk ve çınlama olduğunu belirtmektedir. Bilinç kaybı veya fokal nörolojik defisit tariflememektedir.

Demografi: 49 yaşında erkek hasta | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Atak dışında nörolojik muayenesi doğaldır.
- Sol kulakta düşük frekans işitme azalması şüphesi vardır.
- Otoskopi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Odyometri

Etiket: Odyometri | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Sol kulakta düşük frekanslarda sensörinöral işitme kaybı saptandı. | Klinik anlam: Endolenfatik hidrops ile uyumlu olabilir. | Sonuç yorumu: Endolenfatik hidrops ile uyumlu olabilir. | Sonuç başlığı: Odyometri | Sonuç özeti: Sol kulakta düşük frekanslarda sensörinöral işitme kaybı saptandı. | Yorum: Endolenfatik hidrops ile uyumlu olabilir. | Satırlar: Odyometri / Sol kulakta düşük frekanslarda sensörinöral işitme kaybı saptandı. // Endolenfatik hidrops ile uyumlu olabilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Meniere hastalığı
- B) Benign paroksizmal pozisyonel vertigo
- C) Vestibüler schwannom
- D) Akut otitis media
- E) Otoklerez

Doğru Cevap: Meniere hastalığı

A) Meniere hastalığı: Meniere hastalığı saatler süren vertigo, tinnitus, kulakta dolgunluk ve düşük frekans sensörinöral kayıpla en uyumludur. Vakadaki "Vertigo atakları saatler sürmektedir." ve "Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendirir.

B) Benign paroksizmal pozisyonel vertigo: Benign paroksizmal pozisyonel vertigo saniyeler süren pozisyonla tetiklenen vertigo yapar ve işitme kaybı beklenmez. Bu olguda "Vertigo atakları saatler sürmektedir." ve "Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından Meniere hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Vestibüler schwannom: Vestibüler schwannom daha yavaş ilerleyen tek taraflı işitme kaybı ve denge bozukluğu yapar; saatler süren tipik dolgunluk atakları daha az uyumludur. Bu olguda "Vertigo atakları saatler sürmektedir." ve "Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından Meniere hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Akut otitis media: Akut otitis media otalji, ateş ve otoskopik orta kulak bulgularıyla seyreder; otoskopi doğaldır. Bu olguda "Vertigo atakları saatler sürmektedir." ve "Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından Meniere hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Otoklerez: Otoklerez iletim tipi işitme kaybıyla ilişkilidir; episodik vertigo ve tinnitus-dolgunluk paternini açıklamaz. Bu olguda "Vertigo atakları saatler sürmektedir." ve "Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından Meniere hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tekrarlayan vertigo ve kulakta dolgunluk olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Vertigo atakları saatler sürmektedir." ve "Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda Meniere hastalığı seçeneği öne çıkar; "Odyometride düşük frekans sensörinöral işitme kaybı saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Saatler süren episodik vertigo, tinnitus, kulakta dolgunluk ve dalgalanan düşük frekans sensörinöral işitme kaybı Meniere hastalığını düşündürür.

Temel mekanizma endolenfatik hidrops ile ilişkilidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Vertigo atakları saatler sürmektedir.", "Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir." ve "Odyometride düşük frekans sensörinöral işitme kaybı saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Meniere hastalığı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Vertigo atakları saatler sürmektedir.

Kanıt 2: Ataklara kulakta çınlama ve dolgunluk eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Odyometride düşük frekans sensörinöral işitme kaybı saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Meniere hastalığında vertigo atakları, tinnitus, kulakta dolgunluk ve dalgalanan işitme kaybı birlikte görülür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 363: v195-new-363-alci-sonrasi-artan-bacak-agrisi

Başlık: Alçı sonrası artan bacak ağrısı

Branş: minor-rotations | İlgili Branş: Küçük Stajlar | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Kompartman sendromunda ağrının pasif germe ile artışı ve acil fasyotomi gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Hasta, bacak kırığı sonrası uygulanan alçının ardından giderek artan şiddetli ağrı nedeniyle getiriliyor. Tibia shaft kırığı nedeniyle alçı uygulandığı, son birkaç saatte ağrının verilen analjeziklere rağmen arttığı öğreniliyor. Ayakta uyuşma başlamıştır.

Demografi: 21 yaşında erkek hasta | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bacak gergin ve hassastır.
- Pasif ayak parmak ekstansiyonu ağrıyla belirgin artırır.
- Ayakta parestezi vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kompartman basıncı ölçümü

Etiket: Kompartman basıncı ölçümü | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Anterior kompartman basıncı yüksek saptandı. | Klinik anlam: Klinik tabloyla birlikte kompartman sendromunu destekler. | Sonuç yorumu: Klinik tabloyla birlikte kompartman sendromunu destekler. | Sonuç başlığı: Kompartman basıncı ölçümü | Sonuç özeti: Anterior kompartman basıncı yüksek saptandı. | Yorum: Klinik tabloyla birlikte kompartman sendromunu destekler. | Satırlar: Kompartman basıncı ölçümü / 42 mmHg / / Klinik tabloyla birlikte kompartman sendromunu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastada en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak
- B) Opioid analjezi sonrası ağrı yanıtını izleyip fasyotomi kararını ertelemek
- C) Bacağı sıkı bandajla daha fazla sarmak
- D) Acil cilt biyopsisi yapmak
- E) Egzersizle dolaşımı artırmak

Doğru Cevap: Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak

- A) Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak: Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi hazırlığı yapmak kompartman sendromunda iskemik hasarını önleyen doğru yaklaşımdır. Vakadaki "Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir." ve "Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleştirilir.
- B) Opioid analjezi sonrası ağrı yanıtını izleyip fasyotomi kararını ertelemek: Vakadaki Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir ve Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır. Bu olguda "Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir." ve "Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Bacağı sıkı bandajla daha fazla sarmak: Vakadaki Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir ve Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır. Bu olguda "Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir." ve "Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Acil cilt biyopsisi yapmak: Vakadaki Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir ve Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır. Bu olguda "Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir." ve "Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Egzersizle dolaşımı artırmak: Vakadaki Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir ve Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır. Bu olguda "Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir." ve "Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır." ipuçları tedavi önceliği açısından Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Alçı sonrası artan bacak ağrısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir." ve "Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır." birlikte okunduğunda Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak seçeneği öne çıkar; "Kompartman basıncı yüksek ölçülmüştür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kırık sonrası artan kompartman basıncı, analjezikle geçmeyen ağrı, pasif germe ile ağrının artması ve parestezi akut kompartman sendromunu düşündürür. Kas-sinir iskemisini önlemek için basıyı azaltmak ve acil fasyotomi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir.", "Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır." ve "Kompartman basıncı yüksek ölçülmüştür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Alçıyı gevşetmek ve acil fasyotomi için ortopedik cerrahi hazırlık yapmak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ağrı alçı sonrası giderek artmış ve analjeziklere yanıt vermemiştir.

Kanıt 2: Pasif germe ağrısı belirgin artırmaktadır.

Kanıt 3: Kompartman basıncı yüksek ölçülmüştür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Kompartman sendromunda distal nabız alınabilir; nabız varlığı tanıyı dışlamaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

BRANŞ: pediatrics

VAKA 364: v196-new-364-yemek-sonrasi-ani-solunum-sikintisi

Başlık: Yemek sonrası ani solunum sıkıntısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocukta anafilakside hipotansiyon ve bronkospazm varlığında intramüsküler adrenalinin ilk tedavi olduğunu seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, fıstıklı kek yedikten kısa süre sonra gelişen nefes darlığı, dudak şişliği ve yaygın döküntü nedeniyle getiriliyor. Ailesi, çocuğun daha önce fıstık yedikten sonra ağız çevresinde kaşıntı yaşadığını ancak hiç bu kadar ağır reaksiyon geçirmediğini belirtmektedir. Bugünkü yakınmalar yemekten yaklaşık 10 dakika sonra başlamış; önce boğazda sıkışma hissi, ardından öksürük, karın ağrısı, halsizlik ve yaygın kaşıntılı döküntü gelişmiştir. Evde herhangi bir ilaç verilmemiştir.

Demografi: 8 yaşında erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 76/42 mmHg | Nabız: 154/dk | Solunum: 34/dk | SpO₂: %89% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 2,03 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk korkulu, ajite ve solunum sıkıntılıdır.
- Dudaklarda belirgin anjiyoödem, gövdede yaygın ürtiker, bilateral yaygın hışıltı ve interkostal çekilmeler vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk uygulanması gereken hayat kurtarıcı tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntramüsküler adrenalin uygulamak
B) Antihistaminik temelli semptomatik tedaviyle yetinmek
C) Nebül salbutamol uygulayıp adrenalini ertelemek
D) İn hale bronkodilatör ve antihistaminik sonrası hipotansiyonun seyrine göre adrenalin kararını vermek
E) Oral antibiyotik başlamak

Doğru Cevap: İntramüsküler adrenalin uygulamak

A) İntramüsküler adrenalin uygulamak: İntramüsküler adrenalin anafilakside bronkospazmı, vazodilatasyonu ve kapiller kaçıışı hızlı düzelten ilk hayat kurtarıcı tedavidir. Vakadaki “Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Antihistaminik temelli semptomatik tedaviyle yetinmek: Vakadaki Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır ve Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir. Bu olguda “Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntramüsküler adrenalin uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nebül salbutamol uygulayıp adrenalini ertelemek: Nebül salbutamol bronkospazma yardımcı olabilir fakat sistemik anafilaksinin temel tedavisi olmadığı için adrenalin yerine geçmez. Bu olguda “Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntramüsküler adrenalin uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) İn hale bronkodilatör ve antihistaminik sonrası hipotansiyonun seyrine göre adrenalin kararını vermek: Vakadaki Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır ve Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir. Bu olguda “Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntramüsküler adrenalin uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oral antibiyotik başlamak: Vakadaki Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır ve Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir. Bu olguda “Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntramüsküler adrenalin uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yemek sonrası ani solunum sıkıntısı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.” ve “Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.” birlikte okunduğunda İntramüsküler adrenalin uygulamak seçeneği öne çıkar; “Hipotansiyon, hışıltı ve düşük oksijen satürasyonu solunum-dolaşım etkilenimini kanıtlamaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu olguda gıda maruziyetinden dakikalar sonra deri-mukoza tutulumu, bronkospazm ve hipotansiyon gelişmiştir; bu tablo anafilaksidir. Anafilakside ilk ve en önemli tedavi intramüsküler adrenalindir, çünkü bronkokonstriksiyon, damar geçirgenliği artışı ve dolaşım kollapsını aynı anda hedefler. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.”, “Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.” ve “Hipotansiyon, hışıltı ve düşük oksijen satürasyonu solunum-dolaşım etkilenimini kanıtlamaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntramüsküler adrenalin uygulamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Fıstık alımından yaklaşık 10 dakika sonra sistemik bulgular başlamıştır.

Kanıt 2: Ürtiker ve dudak anjiyoödem deri-mukoza tutulumunu göstermektedir.

Kanıt 3: Hipotansiyon, hışıltı ve düşük oksijen satürasyonu solunum-dolaşım etkilenimini kanıtlamaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Anafilakside antihistaminik destekleyicidir; adrenalin asla geciktirilmemelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 365: v196-new-365-uzamis-jeneralize-nobet

Başlık: Uzamış jeneralize nöbet

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Pediatrik status epileptikusta glukoz kontrolü sonrası benzodiazepinin ilk farmakolojik tedavi olduğunu seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, evde başlayan ve acil servise geldiğinde hâlâ devam eden jeneralize kasılma nedeniyle getiriliyor. Ailesi nöbetin yaklaşık 9 dakikadır sürdüğünü, çocuğun daha önce yalnızca kısa süreli ateşli nöbet geçirdiğini belirtmektedir. Evde diazepam veya başka bir kurtarıcı ilaç verilmemiştir. Son iki gündür üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları vardır; bilinen metabolik hastalık veya travma öyküsü yoktur.

Demografi: 5 yaşında kız çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 146/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.7°C | Şok indeksi: 1,46 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuğun bilinci kapalıdır ve jeneralize tonik-klonik aktivite devam etmektedir.
- Hava yolu pozisyonla desteklenmiş, oksijen verilmiştir.
- Kapiller glukoz 102 mg/dL'dir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk farmakolojik nöbet sonlandırıcı tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uygun yoldan benzodiazepin vermek
B) Oral fenitoin tablet başlamak
C) Antipiretik tedaviyle nöbet kontrolünü izlemek
D) Kültür sonucuna göre antimikrobiyal tedavi planlamak
E) Ketojenik diyeti acil serviste başlatmak

Doğru Cevap: Uygun yoldan benzodiazepin vermek

A) Uygun yoldan benzodiazepin vermek: Benzodiazepin vermek devam eden status epileptikusun ilk farmakolojik tedavisidir ve GABA aracılı inhibisyonu artırarak nöbeti hızla durdurmayı hedefler. Vakadaki “Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.” ve “Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Oral fenitoin tablet başlamak: Oral fenitoin aktif nöbet sırasında güvenilir ve hızlı bir ilk basamak değildir; fenitoin benzeri ilaçlar benzodiazepin sonrası ikinci basamakta düşünülür. Bu olguda “Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.” ve “Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uygun yoldan benzodiazepin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Antipiretik tedaviyle nöbet kontrolünü izlemek: Vakadaki Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir ve Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir. Bu olguda “Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.” ve “Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uygun yoldan benzodiazepin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Kültür sonucuna göre antimikrobiyal tedavi planlamak: Vakadaki Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir ve Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir. Bu olguda “Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.” ve “Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uygun yoldan benzodiazepin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Ketojenik diyeti acil serviste başlatmak: Ketojenik diyet seçilmiş kronik dirençli epilepsilerde düşünülebilir; acil nöbet sonlandırma tedavisi değildir. Bu olguda “Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.” ve “Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Uygun yoldan benzodiazepin vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzamış jeneralize nöbet olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.” ve “Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.” birlikte okunduğunda Uygun yoldan benzodiazepin vermek seçeneği öne çıkar; “Kapiller glukoz normal ölçülmüştür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Beş dakikadan uzun süren aktif jeneralize nöbet status epileptikus yaklaşımı gerektirir. Glukoz değerlendirilmiş ve hipoglisemi dışlanmış olduğundan ilk farmakolojik basamak intravenöz lorazepam/diazepam veya damar yolu yoksa intranazal-bukkal midazolam gibi bir benzodiazepindir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.”, “Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.” ve “Kapiller glukoz normal ölçülmüştür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Uygun yoldan benzodiazepin vermek en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Nöbet yaklaşık 9 dakikadır devam etmektedir.

Kanıt 2: Acilde jeneralize tonik-klonik aktivite sürmektedir.

Kanıt 3: Kapiller glukoz normal ölçülmüştür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Status epileptikusta ilk ilaç benzodiazepindir; ikinci basamak antiepileptikler nöbet sürerse eklenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 366: v196-new-366-havlar-tarzda-oksuruk-ve-cekilme

Başlık: Havlar tarzda öksürük ve çekilme

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Ağır krup atağında istirahat stridor varlığında nebül adrenalin ve sistemik steroid tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, gece aniden artan havlar tarzda öksürük, ses kısıklığı ve gürültülü solunum nedeniyle getiriliyor. Ailesi iki gündür burun akıntısı ve hafif ateş olduğunu, gece uyurken öksürüğün havlar tarzda belirginleştiğini ve çocuğun nefes alırken zorlanmaya başladığını anlatmaktadır. Yabancı cisim aspirasyonu, salya akması veya ani boğulma öyküsü yoktur.

Demografi: 2 yaşında erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 36/dk | SpO₂: %93% | Ateş: 37.9°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk huzursuz ancak uyanıktır.
- İstirahatte inspiratuvar stridor, suprasternal çekilme ve hafif interkostal çekilme vardır.
- Ses kısıktır, havlar tarzda öksürük duyulur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak
B) Oral hidrasyon ve yakın ayaktan izlem planlamak
C) Nebülize salbutamol ve antibiyotik yanıtına göre üst hava yolu tedavisini planlamak
D) Acil tonsillektomi yapmak
E) Antitüberküloz tedaviyi ampirik başlangıç yaklaşımı olarak kullanmak

Doğru Cevap: Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak

- A) Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak: Nebül adrenalin ve deksametazon ağır krup atağında hem hızlı hava yolu rahatlaması hem de kalıcı antiinflamatuvar etki sağlar. Vakadaki "Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- B) Oral hidrasyon ve yakın ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır ve istirahat stridor saptanmıştır. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nebülize salbutamol ve antibiyotik yanıtına göre üst hava yolu tedavisini planlamak: Vakadaki Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır ve istirahat stridor saptanmıştır. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Acil tonsillektomi yapmak: Tonsillektomi krup atağının acil tedavisi değildir; sorun tonsil dokusu değil subglottik ödem ve üst hava yolu daralmasıdır. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Antitüberküloz tedaviyi ampirik başlangıç yaklaşımı olarak kullanmak: Vakadaki Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır ve istirahat stridor saptanmıştır. Bu olguda "Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır." ipuçları tedavi önceliği açısından Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Havlar tarzda öksürük ve çekilme olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır." ve "İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır." birlikte okunduğunda Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak seçeneği öne çıkar; "Suprasternal ve interkostal çekilmeler solunum iş yükünün arttığını göstermektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Havlar tarzda öksürük, ses kısıklığı ve istirahat stridor krup için tipiktir; istirahat stridoru ağır atağı gösterir. Nebül adrenalin üst hava yolu ödemi hızlı azaltır, deksametazon ise inflamasyonu baskılayarak yeniden kötüleşme riskini azaltır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır.", "İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır." ve "Suprasternal ve interkostal çekilmeler solunum iş yükünün arttığını göstermektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nebül adrenalin ve sistemik deksametazon uygulamak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Havlar tarzda öksürük ve ses kısıklığı vardır.

Kanıt 2: İstirahatte inspiratuvar stridor saptanmıştır.

Kanıt 3: Suprasternal ve interkostal çekilmeler solunum iş yükünün arttığını göstermektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Krupta istirahat stridoru varsa yalnız steroid değil, nebül adrenalin de gerekir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 367: v196-new-367-yutamama-ve-tripod-pozisyonu

Başlık: Yutamama ve tripod pozisyonu

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Epiglottit şüphesinde çocuğu ajite etmeden kontrollü hava yolu hazırlığı yapılması gerektiğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş, salya akması ve hızla artan solunum sıkıntısı nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun birkaç saat içinde kötüleştiğini, boğaz ağrısı nedeniyle konuşmak istemediğini ve sıvı içemediğini belirtmektedir. Öksürük belirgin değildir; daha çok sessiz, endişeli ve öne eğik oturmayı tercih etmektedir.

Demografi: 4 yaşında kız çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 150/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 39.6°C | Şok indeksi: 1,50 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk toksik görünümündedir, tripod pozisyonunda oturmakta ve salyasını yutamamaktadır.
- İnspiratuvar stridor hafif duyulur, sesi boğuktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun ilk yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak
B) Dil basacağıyla orofarenksi ayrıntılı muayene etmek
C) Çocuğu ağlatarak daha iyi ağız muayenesi yapmak
D) Kan kültürü alıp intravenöz antibiyotiği hava yolu ekibi hazırlanmadan başlatmak
E) Antipiretik tedaviyle klinik izlemi sürdürmek

Doğru Cevap: Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak

A) Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak: Kontrollü entübasyon hazırlığı epiglottit şüphesinde hava yolu kaybını önlemek için en güvenli ilk yaklaşımdır. Vakadaki "Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır." ve "Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Dil basacağıyla orofarenksi ayrıntılı muayene etmek: Vakadaki Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır ve Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır. Bu olguda "Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır." ve "Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Çocuğu ağlatarak daha iyi ağız muayenesi yapmak: Vakadaki Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır ve Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır. Bu olguda "Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır." ve "Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Kan kültürü alıp intravenöz antibiyotiği hava yolu ekibi hazırlanmadan başlatmak: Vakadaki Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır ve Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır. Bu olguda "Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır." ve "Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Antipiretik tedaviyle klinik izlemi sürdürmek: Vakadaki Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır ve Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır. Bu olguda "Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır." ve "Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yutamama ve tripod pozisyonu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır." ve "Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır." birlikte okunduğunda Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak seçeneği öne çıkar; "Belirgin öksürük olmadan üst hava yolu obstrüksiyonu bulguları gelişmiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yüksek ateş, toksik görünüm, salya akması, yutamama ve tripod pozisyonu epiglottiti düşündürür. Bu tabloda hava yolu ani kapanabileceği için çocuk ajite edilmemeli, boğaz zorla muayene edilmemeli ve deneyimli ekip tarafından kontrollü hava yolu güvenliği sağlanmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır.", "Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır." ve "Belirgin öksürük olmadan üst hava yolu obstrüksiyonu bulguları gelişmiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil hava yolu ekibini çağırıp kontrollü entübasyon hazırlığı yapmak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuk salyasını yutamamakta ve tripod pozisyonunda oturmaktadır.

Kanıt 2: Yüksek ateş ve toksik görünüm vardır.

Kanıt 3: Belirgin öksürük olmadan üst hava yolu obstrüksiyonu bulguları gelişmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Epiglottitte agresif boğaz muayenesi hava yolunu tamamen kapatabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 368: v196-new-368-ishal-sonrasi-dolasim-bozuklugu

Başlık: İshal sonrası dolaşım bozukluğu

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Hipovolemik şoktaki çocukta oral rehidratasyon yerine izotonik kristalloid bolus verilmesi gerektiğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yoğun kusma-ışhal sonrası halsizlik, gözlerde çökme ve idrar yapmama nedeniyle getiriliyor. Son 24 saatte çok sayıda sulu dışkılama ve tekrarlayan kusma olduğu, son 10 saattir bezinin kuru kaldığı öğreniliyor. Aile evde az miktarda su verebilmiş, ancak çocuk her içtiğini kusmuştur. Kanlı dışkı veya bilinen kronik hastalık yoktur.

Demografi: 16 aylık erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/38 mmHg | Nabız: 174/dk | Solunum: 34/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 2,49 (yüksek)

Fizik Muayene

- Gözleri çökmüş, mukozaları kurudur.
- Kapiller dolum 4 saniyedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yatak başı kan glukozu

Etiket: Yatak başı kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Hipoglisemi şok bulgularını açıklamamaktadır. | Sonuç yorumu: Hipoglisemi şok bulgularını açıklamamaktadır. | Sonuç başlığı: Yatak başı kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Hipoglisemi şok bulgularını açıklamamaktadır. | Satırlar: Yatak başı kan glukozu / 91 mg/dL / 70-100 mg/dL / Hipoglisemi şok bulgularını açıklamamaktadır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk resüsitasyon tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek
- B) Oral rehidratasyon sıvısını küçük yudumlarla denemek
- C) Loperamid başlamak
- D) Sıvı alımını kısıtlamak
- E) Probiyotik ve oral hidrasyonla destek tedavisi planlamak

Doğru Cevap: İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek

A) İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek: İzotonik kristalloid bolusu hipovolemik şokta intravasküler hacmi hızlı destekleyen doğru ilk tedavidir. Vakadaki “Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Oral rehidratasyon sıvısını küçük yudumlarla denemek: Oral rehidratasyon hafif-orta dehidratasyonda uygundur ancak hipotansif ve letarjik çocukta ilk seçenek değildir. Bu olguda “Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Loperamid başlamak: Vakadaki Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır ve Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır. Bu olguda “Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Sıvı alımını kısıtlamak: Sıvı kısıtlamak hipovolemiyi artırır; hipotansiyon, soğuk ekstremitte ve uzamış kapiller dolum varken dolaşım hacmini desteklemek gerekir. Bu olguda “Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Probiyotik ve oral hidrasyonla destek tedavisi planlamak: Vakadaki Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır ve Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır. Bu olguda “Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: İshal sonrası dolaşım bozukluğu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.” ve “Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.” birlikte okunduğunda İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek seçeneği öne çıkar; “Kapiller dolum süresi 4 saniyeye uzamıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çocukta taşikardi, hipotansiyon, soğuk ekstremitte, zayıf nabız ve uzamış kapiller dolum hipovolemik şoku gösterir. Şoktaki çocukta oral rehidratasyon yeterli değildir; ilk yaklaşım intravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusudur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.”, “Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.” ve “Kapiller dolum süresi 4 saniyeye uzamıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz veya intraosseöz izotonik kristalloid bolusu vermek en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yoğun kusma-ışhal sonrası uzun süredir idrar çıkışı olmamıştır.

Kanıt 2: Hipotansiyon, taşikardi ve soğuk ekstremitte vardır.

Kanıt 3: Kapiller dolum süresi 4 saniyeye uzamıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Şok bulgusu olan dehidratasyonda ilk tedavi oral değil parenteral izotonik sıvıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 369: v196-new-369-kilo-kaybi-ve-derin-solunum

Başlık: Kilo kaybı ve derin solunum

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Çocuk diyabetik ketoasidozunda ilk yaklaşımın izotonik sıvı ve potasyum izlemi olduğunu seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, kusma, karın ağrısı, çok su içme ve derin hızlı solunum nedeniyle getiriliyor. Son üç haftadır belirgin susama, sık idrara çıkma ve kilo kaybı olduğu; son 12 saatte kusma ve halsizliğin eklendiği öğreniliyor. Ailede tip 1 diyabet öyküsü vardır. Bilinen diyabet tanısı daha önce konmamıştır.

Demografi: 10 yaşında kız çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 136/dk | Solunum: 32/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,55 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk dehidrate, halsiz ve yanıtları yavaştır.
- Kussmaul solunumu ve nefeste aseton kokusu vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır hiperglisemi vardır. | Sonuç yorumu: Ağır hiperglisemi vardır. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Ağır hiperglisemi vardır. | Satırlar: Kan glukozu / 512 mg/dL / 70-140 mg/dL / Ağır hiperglisemi vardır.

Tetkik 2: Venöz kan gazı

Etiket: Venöz kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Ketoasidozu destekler. | Sonuç yorumu: Ketoasidozu destekler. | Sonuç başlığı: Venöz kan gazı | Sonuç özeti: Yüksek anyon açıklıklı metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Ketoasidozu destekler. | Satırlar: Venöz kan gazı / pH 7.11, HCO₃ 7 mmol/L / / Ketoasidozu destekler.

Tetkik 3: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal-yüksek saptandı. | Klinik anlam: Toplam vücut potasyumu azalmış olabilir. | Sonuç yorumu: Toplam vücut potasyumu azalmış olabilir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Normal-yüksek saptandı. | Yorum: Toplam vücut potasyumu azalmış olabilir. | Satırlar: Serum potasyum / 5.0 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Toplam vücut potasyumu azalmış olabilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun başlangıç tedavi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak
- B) Yüksek doz insülini bolus şeklinde hemen uygulamak
- C) Rutin bikarbonat verip sıvıyı ertelemek
- D) Oral antidiyabetik başlamak
- E) Diüretik vererek glukozu düşürmek

Doğru Cevap: İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak

A) İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak: İzotonik sıvı, potasyum izlemi ve dikkatli insülin planı çocuk DKA'da güvenli başlangıç yaklaşımıdır. Vakadaki "Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir." ve "Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Yüksek doz insülini bolus şeklinde hemen uygulamak: Vakadaki Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir ve Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir. Bu olguda "Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir." ve "Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Rutin bikarbonat verip sıvıyı ertelemek: Bikarbonat rutin değildir ve sıvı resüsitasyonunun yerini tutmaz; çocuk DKA'da seçilmiş çok ağır asidoz dışında zarar riski taşıyabilir. Bu olguda "Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir." ve "Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral antidiyabetik başlamak: Oral antidiyabetik akut ketoasidozu tedavi etmez; bu olguda asidoz, dehidratasyon ve ketotik metabolik bozukluk parenteral acil yaklaşım gerektirir. Bu olguda "Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir." ve "Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Diüretik vererek glukozu düşürmek: Diüretik dehidratasyonu artırır ve ketoasidozu düzeltmez; çocukta dolaşım hacmi ve elektrolit dengesi öncelikle güvenli şekilde düzeltilmelidir. Bu olguda "Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir." ve "Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir." ipuçları tedavi önceliği açısından İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kilo kaybı ve derin solunum olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir." ve "Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak seçeneği öne çıkar; "Kussmaul solunumu ve dehidratasyon klinik ketoasidozu desteklemektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Bu tablo yeni başlangıçlı tip 1 diyabet zemininde diyabetik ketoasidozu düşündürür. Çocuk DKA'da ilk yaklaşım dolaşım ve dehidratasyonu düzeltmek için izotonik sıvıdır; insülin infüzyonu potasyum durumu ve sıvı tedavisi değerlendirildikten sonra dikkatli başlanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir.", "Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir." ve "Kussmaul solunumu ve dehidratasyon klinik ketoasidozu desteklemektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İzotonik sıvı tedavisi başlamak, potasyumu izlemek ve insülini dikkatli planlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Poliüri, polidipsi ve kilo kaybı diyabet başlangıcını desteklemektedir.

Kanıt 2: Hiperglisemiye metabolik asidoz eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Kussmaul solunumu ve dehidratasyon klinik ketoasidozu desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Çocuk DKA'da hızlı osmolalite değişimlerinden kaçınmak gerekir; sıvı ve potasyum planı tedavinin temelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 370: v196-new-370-bobrek-yetmezliginde-ritim-riski

Başlık: Böbrek yetmezliğinde ritim riski

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: EKG değişikliği olan hiperkalemiye intravenöz kalsiyum glukonatın ilk acil tedavi olduğunu seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, kronik böbrek hastalığı zemininde halsizlik, kas güçsüzlüğü ve çarpıntı nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun planlı diyaliz seansını kaçırdığını ve son gün potasyumdan zengin gıdalar tükettiğini belirtmektedir. Son saatlerde bacaklarda güçsüzlük ve göğüste çarpıntı hissi gelişmiştir.

Demografi: 12 yaşında erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 48/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 0,51

Fizik Muayene

- Çocuk halsizdir.
- Bilinç açıktır ancak bitkindir.
- Solunum sıkıntısı belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır hiperkalemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Ağır hiperkalemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Ağır hiperkalemiyi gösterir. | Satırlar: Serum potasyum / 7.2 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Ağır hiperkalemiyi gösterir.

Tetkik 2: Elektrokardiyografi

Etiket: Elektrokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Klinik anlam: Hiperkaleminin kardiyak membran etkisini gösterir. | Sonuç yorumu: Hiperkaleminin kardiyak membran etkisini gösterir. | Sonuç başlığı: Elektrokardiyografi | Sonuç özeti: Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Yorum: Hiperkaleminin kardiyak membran etkisini gösterir. | Satırlar: Elektrokardiyografi / Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. // Hiperkaleminin kardiyak membran etkisini gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-188 | Başlık: Elektrokardiyografi | Modalite: ecg | Bulgu: Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Klinik anlam: Hiperkaleminin kardiyak membran etkisini gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/188_hiperkalemi_sivri_t_qrs_genislemesi_ekg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/188_hiperkalemi_sivri_t_qrs_genislemesi_ekg.webp | Alt text: Elektrokardiyografi - Sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta ilk acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak
- B) Oral potasyum replasmanı yapmak
- C) Reçine tedavisi vererek ayaktan izlem planlamak
- D) Beta bloker başlamak
- E) Potasyumdan zengin diyet önermek

Doğru Cevap: İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak

A) İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak: İntravenöz kalsiyum glukonat EKG değişikliği olan hiperkalemiye miyokardı stabilize eden ilk acil tedavidir. Vakadaki "Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir." ve "EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Oral potasyum replasmanı yapmak: Vakadaki Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir ve EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır. Bu olguda "Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir." ve "EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Reçine tedavisi vererek ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir ve EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır. Bu olguda "Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir." ve "EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Beta bloker başlamak: Vakadaki Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir ve EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır. Bu olguda "Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir." ve "EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Potasyumdan zengin diyet önermek: Vakadaki Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir ve EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır. Bu olguda "Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir." ve "EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Böbrek yetmezliğinde ritim riski olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir." ve "EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır." birlikte okunduğunda İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak seçeneği öne çıkar; "Hastada çarpıntı ve düzensiz-yavaş nabız saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ağır hiperkalemiye EKG değişikliği eşlik ettiğinde ilk hedef potasyumu hemen düşürmekten önce miyokard membranını stabilize etmektir. İntravenöz kalsiyum glukonat aritmi riskini hızla azaltır; ardından potasyumu hücre içine kaydıran ve vücuttan uzaklaştıran tedaviler eklenir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir.", "EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır." ve "Hastada çarpıntı ve düzensiz-yavaş nabız saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz kalsiyum glukonat uygulamak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Serum potasyumu 7.2 mmol/L olarak belirgin yüksektir.

Kanıt 2: EKG'de sivri T dalgaları ve QRS genişlemesi vardır.

Kanıt 3: Hastada çarpıntı ve düzensiz-yavaş nabız saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Hiperkalemiye EKG değişikliği varsa ilk acil ilaç intravenöz kalsiyumdur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 371: v196-new-371-konusamama-ve-hisilti

Başlık: Konuşamama ve hisilti

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Ağır astım atağında hipoksemi ve konuşamama bulgularıyla yoğun bronkodilatör ve steroid tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, giderek artan nefes darlığı ve kurtarıcı inhalere rağmen düzelmeyen hisilti nedeniyle getiriliyor. Bilinen astımı vardır. Son iki gündür viral üst solunum yolu bulguları sonrası gece öksürüğü ve inhaler ihtiyacı artmıştır. Bugün okulda merdiven çıkarken belirgin nefes darlığı gelişmiş, eve geldiğinde cümle kurmakta zorlanmıştır.

Demografi: 9 yaşında erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 148/dk | Solunum: 38/dk | SpO₂: %87% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 1,80 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk öne eğilerek oturmakta, tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı solunum kaslarını kullanmaktadır.
- Yaygın hisilti vardır; ekspirasyon uzundur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak
B) Antihistaminik temelli semptomatik tedaviyle yetinmek
C) Solunum egzersiziyle semptom kontrolü sağlamaya çalışmak
D) Kültür sonucuna göre antimikrobiyal tedavi planlamak
E) Tek doz kısa etkili beta-agonist sonrası tedaviyi kültür sonucuna göre daraltmak

Doğru Cevap: Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak

- A) Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak: Oksijen, kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik steroid ağır astım atağında hipoksemi ve bronkospazmı hedefleyen doğru başlangıç tedavisidir. Vakadaki “Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.” ve “Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Antihistaminik temelli semptomatik tedaviyle yetinmek: Vakadaki Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir ve Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır. Bu olguda “Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.” ve “Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Solunum egzersiziyle semptom kontrolü sağlamaya çalışmak: Vakadaki Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir ve Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır. Bu olguda “Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.” ve “Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Kültür sonucuna göre antimikrobiyal tedavi planlamak: Vakadaki Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir ve Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır. Bu olguda “Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.” ve “Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Tek doz kısa etkili beta-agonist sonrası tedaviyi kültür sonucuna göre daraltmak: Vakadaki Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir ve Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır. Bu olguda “Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.” ve “Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Konuşamama ve hisilti olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.” ve “Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.” birlikte okunduğunda Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak seçeneği öne çıkar; “Yaygın hisilti ve uzamış ekspirasyon vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Hipoksemi, tek kelimeyle konuşma, yardımcı kas kullanımı ve yaygın hisilti ağır astım atağını gösterir. Başlangıç tedavisi oksijen, sık tekrarlanan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid kombinasyonudur. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.”, “Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.” ve “Yaygın hisilti ve uzamış ekspirasyon vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oksijen, tekrarlayan kısa etkili beta-agonist, ipratropium ve sistemik kortikosteroid uygulamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Oksijen satürasyonu oda havasında %87’dir.

Kanıt 2: Çocuk tek kelimelerle konuşmakta ve yardımcı kas kullanmaktadır.

Kanıt 3: Yaygın hisilti ve uzamış ekspirasyon vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Ağır astım atağında sistemik steroid erken verilmeli, bronkodilatör tedavi sık tekrarlanmalıdır.

Kalite notu: ID sorundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 372: v196-new-372-yenidoganda-titreme-ve-emme-zayifligi

Başlık: Yenidoğanda titreme ve emme zayıflığı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Semptomatik yenidoğan hipoglisemisinde intravenöz dekstroz tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, titreme, emmede azalma ve solukluk nedeniyle yenidoğan ekibi tarafından değerlendiriliyor. Annenin gestasyonel diyabeti olduğu ve bebeğin gebelik haftasına göre iri doğduğu öğreniliyor. İlk beslenme girişiminde bebek kısa süre emmiş, ardından uykuya eğilim ve titreme gelişmiştir. Doğumda ciddi asfiksi öyküsü yoktur.

Demografi: 4 saatlik erkek yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirmesi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 162/dk | Solunum: 48/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 36.6°C | Şok indeksi: 2,31 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek iritabl, tremorlu ve emmesi zayıftır.
- Cilt rengi soluktur.
- Hipotoni veya belirgin solunum sıkıntısı yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Yatak başı kan glukozu

Etiket: Yatak başı kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Semptomatik neonatal hipoglisemiyi destekler. | Sonuç yorumu: Semptomatik neonatal hipoglisemiyi destekler. | Sonuç başlığı: Yatak başı kan glukozu | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Semptomatik neonatal hipoglisemiyi destekler. | Satırlar: Yatak başı kan glukozu / 27 mg/dL / / Semptomatik neonatal hipoglisemiyi destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yenidoğanda en uygun acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak
B) İnsülin uygulamak
C) Su vermek
D) Enteral beslenmeyle yanıtı izleyip intravenöz dekstrozu semptom sürerse başlamak
E) Oral antibiyotik vermek

Doğru Cevap: İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak

A) İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak: İntravenöz dekstroz semptomatik neonatal hipoglisemide glukozu hızlı ve kontrollü yükselten doğru tedavidir. Vakadaki “Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.” ve “Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) İnsülin uygulamak: İnsülin mevcut hipoglisemiyi artırır; diyabetik anne bebeğinde sorun hiperinsülinemiye bağlı düşük glukozdur ve dekstroz gerekir. Bu olguda “Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.” ve “Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Su vermek: Vakadaki Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur ve Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır. Bu olguda “Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.” ve “Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
D) Enteral beslenmeyle yanıtı izleyip intravenöz dekstrozu semptom sürerse başlamak: Vakadaki Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur ve Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır. Bu olguda “Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.” ve “Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Oral antibiyotik vermek: Oral antibiyotik hipoglisemi mekanizmasını tedavi etmez; bu olguda temel sorun enfeksiyon değil düşük kan glukozuna bağlı nörolojik risktir. Bu olguda “Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.” ve “Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda titreme ve emme zayıflığı olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.” ve “Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.” birlikte okunduğunda İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak seçeneği öne çıkar; “Yatak başı glukoz 27 mg/dL olarak belirgin düşüktür.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Diyabetik anne bebeklerinde fetal hiperinsülinemi nedeniyle erken neonatal hipoglisemi gelişebilir. Titreme ve emme zayıflığı gibi semptomlarla birlikte belirgin düşük glukoz varsa intravenöz dekstroz tedavisi geciktirilmemelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.”, “Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.” ve “Yatak başı glukoz 27 mg/dL olarak belirgin düşüktür.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz dekstroz tedavisi başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebek diyabetik anne bebeğidir ve iri doğmuştur.

Kanıt 2: Titreme ve emme zayıflığı hipoglisemi semptomlarıdır.

Kanıt 3: Yatak başı glukoz 27 mg/dL olarak belirgin düşüktür.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığına seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamaya yerine geçmez.

Exam Pearl: Semptomatik neonatal hipoglisemi nörolojik hasar riski nedeniyle hızlı dekstroz tedavisi gerektirir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 373: v196-new-373-kanli-ishal-sonrasi-idrar-azalması

Başlık: Kanlı ishal sonrası idrar azalması

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Kanlı ishal sonrası HUS tablosunda mikroanjiyopatik hemoliz, trombositopeni ve böbrek hasarını tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, birkaç gün önce başlayan kanlı ishalin ardından solukluk, halsizlik ve idrar miktarında azalma nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun bir hafta önce iyi pişmemiş hamburger yediğini, ardından şiddetli karın ağrısı ve kanlı dışkılama geliştiğini belirtmektedir. İshal azalmaya başlarken halsizlik, göz çevresinde şişlik ve daha az idrar yapma fark edilmiştir.

Demografi: 5 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 116/76 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98 | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 0,88

Fizik Muayene

- Çocuk soluk ve halsizdir.
- Hafif periorbital ödem vardır.
- Karın yumuşaktır, yaygın peritonit bulgusu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Anemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Anemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Anemiyi gösterir. | Satırlar: Hemoglobin / 7.7 g/dL // Anemiyi gösterir.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Trombositopeniyi gösterir. | Sonuç yorumu: Trombositopeniyi gösterir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Trombositopeniyi gösterir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 58000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Trombositopeniyi gösterir.

Tetkik 3: Serum kreatinin

Etiket: Serum kreatinin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut böbrek hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Akut böbrek hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Serum kreatinin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut böbrek hasarını destekler. | Satırlar: Serum kreatinin / 1.7 mg/dL // Akut böbrek hasarını destekler.

Tetkik 4: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjiyopatik hemolitik anemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Mikroanjiyopatik hemolitik anemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Şistositler izlendi. | Yorum: Mikroanjiyopatik hemolitik anemiyi gösterir. | Satırlar: Periferik yayma / Şistositler izlendi. / Mikroanjiyopatik hemolitik anemiyi gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-189 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Şistositler izlendi. | Klinik anlam: Mikroanjiyopatik hemolitik anemiyi gösterir. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/189_hus_sistosit_periferik_yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/189_hus_sistosit_periferik_yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Şistositler izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hemolitik üremik sendrom
B) İmmün trombositopeni
C) Nefrotik sendrom
D) Akut romatizmal ateş
E) Viral gastroenterit sonrası basit dehidratasyon

Doğru Cevap: Hemolitik üremik sendrom

- A) Hemolitik üremik sendrom: Hemolitik üremik sendrom kanlı ishal sonrası şistositli hemoliz, trombositopeni ve böbrek hasarıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.” ve “Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) İmmün trombositopeni: İmmün trombositopeni genellikle izole trombositopeni yapar; şistositli hemoliz ve böbrek hasarı beklenmez. Bu olguda “Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.” ve “Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Hemolitik üremik sendrom seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nefrotik sendrom: Nefrotik sendrom ağır proteinüri ve hipalbuminemiyle seyreder; trombositopeni ve şistosit temel bulgu değildir. Bu olguda “Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.” ve “Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Hemolitik üremik sendrom seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Akut romatizmal ateş: Akut romatizmal ateş farenjit sonrası kardit ve artrit ile ilişkilidir; kanlı ishal sonrası renal mikroanjiyopatiji açıklamaz. Bu olguda “Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.” ve “Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Hemolitik üremik sendrom seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Viral gastroenterit sonrası basit dehidratasyon: Basit dehidratasyon trombositopeni ve şistositli hemoliz oluşturmaz; bu bulgular kanlı ishal sonrası mikroanjiyopatik süreci düşündürür. Bu olguda “Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.” ve “Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Hemolitik üremik sendrom seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kanlı ishal sonrası idrar azalması olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.” ve “Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.” birlikte okunduğunda Hemolitik üremik sendrom seçeneği öne çıkar; “Kreatinin yüksekliği ve idrar azalması akut böbrek hasarını desteklemektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kanlı ishal sonrası gelişen mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek hasarı hemolitik üremik sendrom için tipiktir. Shiga toksini ilişkili endotel hasarı küçük damar trombozu ve renal etkilenime yol açar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.”, “Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.” ve “Kreatinin yüksekliği ve idrar azalması akut böbrek hasarını desteklemektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Hemolitik üremik sendrom en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kanlı ishal iyi pişmemiş et tüketimi sonrası gelişmiştir.

Kanıt 2: Şistositli anemi ve trombositopeni vardır.

Kanıt 3: Kreatinin yüksekliği ve idrar azalması akut böbrek hasarını desteklemektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: HUS triadı mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek hasarındır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 374: v196-new-374-ates-ve-ense-sertligi

Başlık: Ateş ve ense sertliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Bakteriyel menenjit şüphesinde ampirik intravenöz antibiyotiğin geciktirilmemesi gerektiğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma ve uykuya eğilim nedeniyle getiriliyor. Ailesi son 12 saatte çocuğun hızla kötüleştiğini, ışığa bakmak istemediğini ve birkaç kez fışkırır tarzda kusması olduğunu belirtmektedir. Kafa travması öyküsü yoktur. Aşı kayıtları eksiktir.

Demografi: 7 yaşında erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 92/56 mmHg | Nabız: 136/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 39.4°C | Şok indeksi: 1,48 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk letarjik görünmektedir.
- Ense sertliği ve fotofobi vardır.
- Peteşi izlenmez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lökositoz ve nötrofili saptandı. | Klinik anlam: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lökositoz ve nötrofili saptandı. | Yorum: Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler. | Satırlar: Tam kan sayımı / Lökositoz ve nötrofili saptandı. // Bakteriyel enfeksiyon olasılığını destekler.

Tetkik 2: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Ağır inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Ağır inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 118 mg/L / <5 mg/L / Ağır inflamasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak
- B) Klinik stabiliteyi izleyip antibiyotik kararını ertelemek
- C) Analjezik tedavi vererek ayaktan izlem planlamak
- D) Aşı kayıtları bulunana kadar tedavi vermemek
- E) Antihistaminik temelli semptomatik tedaviyle yetinmek

Doğru Cevap: Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak

A) Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak: Kan kültürü sonrası ampirik intravenöz antibiyotik başlamak bakteriyel menenjit şüphesinde doğru acil yaklaşımdır. Vakadaki “Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekçidir.

B) Klinik stabiliteyi izleyip antibiyotik kararını ertelemek: Vakadaki Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır ve Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Analjezik tedavi vererek ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır ve Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Aşı kayıtları bulunana kadar tedavi vermemek: Aşı öyküsü önemli olsa da acil tedaviyi erteleme nedeni değildir; klinik menenjit şüphesi varsa ampirik antibiyotik başlanmalıdır. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Antihistaminik temelli semptomatik tedaviyle yetinmek: Vakadaki Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır ve Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir. Bu olguda “Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve ense sertliği olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.” ve “Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.” birlikte okunduğunda Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak seçeneği öne çıkar; “Nötrofilik lökositoz ve yüksek CRP bakteriyel enfeksiyonu desteklemektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, ense sertliği, fotofobi, kusma ve bilinç değişikliği bakteriyel menenjit açısından acildir. Kan kültürü alınmalı, ancak lomber ponksiyon veya görüntüleme herhangi bir nedenle gecikecekse ampirik intravenöz antibiyotik tedavisi geciktirilmemelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.”, “Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.” ve “Nötrofilik lökositoz ve yüksek CRP bakteriyel enfeksiyonu desteklemektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik tedavisini geciktirmeden başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yüksek ateş, baş ağrısı, fotofobi ve kusma vardır.

Kanıt 2: Ense sertliği ve letarji meningeal tutulum düşündürmektedir.

Kanıt 3: Nötrofilik lökositoz ve yüksek CRP bakteriyel enfeksiyonu desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Menenjit şüphesinde antibiyotik tedavisi tanısal işlemler gecikirse bekletilmez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 375: v196-new-375-tablet-alimi-sonrasi-kusma-ve-sok

Başlık: Tablet alımı sonrası kusma ve şok

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Demir zehirlenmesinde ciddi toksisite bulgularıyla deferoksamin tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, evde çok sayıda demir tableti yuttuktan sonra tekrarlayan kusma, karın ağrısı ve halsizlik nedeniyle getiriliyor. Aile, annenin demir tabletlerinden yaklaşık 20 tabletin eksildiğini fark ettiğini belirtmektedir. Alımdan yaklaşık 2 saat sonra çocukta kanlı olmayan kusma, karın ağrısı, terleme ve uykuya eğilim gelişmiştir. Aktif kömür evde verilmemiştir.

Demografi: 3 yaşında kız çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 76/44 mmHg | Nabız: 158/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 2,08 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk soluk, bitkin ve dehidrate görünmektedir.
- Karında yaygın hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum demir düzeyi

Etiket: Serum demir düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Toksik aralıkta yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır demir zehirlenmesini destekler. | Sonuç yorumu: Ağır demir zehirlenmesini destekler. | Sonuç başlığı: Serum demir düzeyi | Sonuç özeti: Toksik aralıkta yüksek saptandı. | Yorum: Ağır demir zehirlenmesini destekler. | Satırlar: Serum demir düzeyi / 640 µg/dL // Ağır demir zehirlenmesini destekler.

Tetkik 2: Kan gazı

Etiket: Kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Sistemik toksisiteyi gösterir. | Sonuç yorumu: Sistemik toksisiteyi gösterir. | Sonuç başlığı: Kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Sistemik toksisiteyi gösterir. | Satırlar: Kan gazı / pH 7.21, HCO₃ 12 mmol/L // Sistemik toksisiteyi gösterir.

Tetkik 3: Abdominal grafi

Etiket: Abdominal grafi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Mide projeksiyonunda radyoopak tablet yoğunlukları izlendi. | Klinik anlam: Demir tablet alımını destekler. | Sonuç yorumu: Demir tablet alımını destekler. | Sonuç başlığı: Abdominal grafi | Sonuç özeti: Mide projeksiyonunda radyoopak tablet yoğunlukları izlendi. | Yorum: Demir tablet alımını destekler. | Satırlar: Abdominal grafi / Mide projeksiyonunda radyoopak tablet yoğunlukları izlendi. // Demir tablet alımını destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-190 | Başlık: Abdominal grafi | Modalite: xray | Bulgu: Mide projeksiyonunda radyoopak tablet yoğunlukları izlendi. | Klinik anlam: Demir tablet alımını destekler. | URL: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/190_demir_tablet_alimi_abdominal_grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixctqdsd.public.blob.vercel-storage.com/190_demir_tablet_alimi_abdominal_grafi.webp | Alt text: Abdominal grafi - Mide projeksiyonunda radyoopak tablet yoğunlukları izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta uygun spesifik tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Deferoksamin tedavisi uygulamak
- B) Aktif kömürü tek spesifik tedavi olarak vermek
- C) Nalokson uygulamak
- D) Vitamin K vermek
- E) Oral sıvı alımıyla gastrointestinal dekontaminasyona güvenmek

Doğru Cevap: Deferoksamin tedavisi uygulamak

A) Deferoksamin tedavisi uygulamak: Deferoksamin demiri bağlayarak ağır demir zehirlenmesinde kullanılan uygun spesifik şelasyon tedavisidir. Vakadaki “Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.” ve “Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Aktif kömürü tek spesifik tedavi olarak vermek: Vakadaki Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır ve Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir. Bu olguda “Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.” ve “Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Nalokson uygulamak: Vakadaki Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır ve Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir. Bu olguda “Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.” ve “Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Vitamin K vermek: Vitamin K warfarin etkisini geri çevirmek için kullanılır; demir toksisitesine etkili değildir. Bu olguda “Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.” ve “Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oral sıvı alımıyla gastrointestinal dekontaminasyona güvenmek: Vakadaki Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır ve Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir. Bu olguda “Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.” ve “Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Deferoksamin tedavisi uygulamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tablet alımı sonrası kusma ve şok olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.” ve “Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.” birlikte okunduğunda Deferoksamin tedavisi uygulamak seçeneği öne çıkar; “Serum demir düzeyi toksik aralıkta yüksektir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Demir zehirlenmesinde şok, metabolik asidoz ve çok yüksek serum demiri ciddi sistemik toksisiteyi gösterir. Aktif kömür demiri etkili bağlamaz; ağır zehirlenmede deferoksamin şelasyonu gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.”, “Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.” ve “Serum demir düzeyi toksik aralıkta yüksektir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Deferoksamin tedavisi uygulamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çok sayıda demir tableti alımı öyküsü vardır.

Kanıt 2: Hipotansiyon, uzamış kapiller dolum ve metabolik asidoz sistemik toksisiteyi göstermektedir.

Kanıt 3: Serum demir düzeyi toksik aralıkta yüksektir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Demir zehirlenmesinde aktif kömür etkisizdir; ağır olguda deferoksamin kullanılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 376: v196-new-376-kuruyemis-sonrasi-tek-tarafli-hisilti

Başlık: Kuruyemiş sonrası tek taraflı hisilti

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Uygun tanısal testi klinik bağlamla seçme.

Learning Target: Yabancı cisim aspirasyonunda ani öksürük ve tek taraflı hava hapsiyle rijid bronkoskopi gereksinimini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, kuruyemiş yerken aniden başlayan öksürük krizi ve sonrasında devam eden hisilti nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun fındık yerken birden öksürmeye başladığını, kısa süre morardığını ve sonrasında kısmen rahatladığını anlatmaktadır. Ancak olaydan sonra sağ tarafta hisilti ve huzursuzluk devam etmiştir. Ateş veya öncesinde enfeksiyon bulgusu yoktur.

Demografi: 22 aylık erkek çocuk | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %94% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,56 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk huzursuzdur ancak konuşma/ ağlama sesi çıkarabilmektedir.
- Sağ hemitoraksta solunum sesleri belirgin azalmış ve tek taraflı hisilti duyulmaktadır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ akciğerde hava hapsiyle uyumlu hiperinflasyon izlendi. | Klinik anlam: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Sağ akciğerde hava hapsiyle uyumlu hiperinflasyon izlendi. | Yorum: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | Satırlar: Akciğer grafisi / Sağ akciğerde hava hapsiyle uyumlu hiperinflasyon izlendi. // Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-191 | Başlık: Akciğer grafisi | Modalite: xray | Bulgu: Sağ akciğerde hava hapsiyle uyumlu hiperinflasyon izlendi. | Klinik anlam: Parsiyel bronş obstrüksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/191_yabanci_cisim_aspirasyonu_hiperinflasyon_grafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/191_yabanci_cisim_aspirasyonu_hiperinflasyon_grafi.webp | Alt text: Akciğer grafisi - Sağ akciğerde hava hapsiyle uyumlu hiperinflasyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun tanısal ve tedavi edici yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Rijid bronkoskopi
B) Planlı alerji testi
C) Antitussif semptomatik tedavi
D) Kontrol tedavisi olarak astım tedavisi başlamak
E) Bronkodilatör yanıtını izleyip bronkoskopiye dirençli hisiltiyi saklamak

Doğru Cevap: Rijid bronkoskopi

- A) Rijid bronkoskopi: Rijid bronkoskopi yabancı cisim aspirasyonunda hava yolundaki cismi görüp çıkarmayı sağlayan uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Planlı alerji testi: Vakadaki Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır ve Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır. Bu olguda “Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijid bronkoskopi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Antitussif semptomatik tedavi: Antitussif semptomatik tedavi, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda “Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijid bronkoskopi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Kontrol tedavisi olarak astım tedavisi başlamak: Kontrol tedavisi olarak astım tedavisi başlamak, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda “Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijid bronkoskopi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Bronkodilatör yanıtını izleyip bronkoskopiye dirençli hisiltiyi saklamak: Bronkodilatör yanıtını izleyip bronkoskopiye dirençli hisiltiyi saklamak, benzer klinik başlıklarda akla gelebilecek bir çeldiricidir. Bu olguda “Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Rijid bronkoskopi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kuruyemiş sonrası tek taraflı hisilti olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.” ve “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.” birlikte okunduğunda Rijid bronkoskopi seçeneği öne çıkar; “Grafide sağ akciğerde hava hapsi izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ani boğulma-öksürük atağı, tek taraflı solunum azalması, tek taraflı hisilti ve hava hapsi yabancı cisim aspirasyonunu düşündürür. Rijid bronkoskopi hem tanı koyar hem de yabancı cismin çıkarılmasını sağlar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.”, “Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.” ve “Grafide sağ akciğerde hava hapsi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Rijid bronkoskopi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Yakınmalar kuruyemiş yerken aniden başlamıştır.

Kanıt 2: Sağ hemitoraksta solunum sesleri azalmış ve tek taraflı hisilti vardır.

Kanıt 3: Grafide sağ akciğerde hava hapsi izlenmiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Yabancı cisim aspirasyonunda bronkoskopi tanısal ve tedavi edicidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 377: v196-new-377-ates-ve-tek-dizde-sislik

Başlık: Ateş ve tek dizde şişlik

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Septik artritte ateşli akut monoartritte eklem aspirasyonu ve intravenöz antibiyotik yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yüksek ateş ve sağ dizini hareket ettirememe nedeniyle getiriliyor. Ağrının dün akşam başladığı, sabah çocuğun yürümek istemediği ve dizini büküp açmaya izin vermediği öğreniliyor. Travma, bilinen romatolojik hastalık veya yakın zamanda aşı öyküsü yoktur.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 39.1°C | Şok indeksi: 1,50 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ diz belirgin şiş, sıcak, kızarık ve çok hassastır.
- Pasif hareketle şiddetli ağrı oluşur.
- Çocuk diz üzerine basmak istemez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Akut inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Akut inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 104 mg/L / <5 mg/L / Akut inflamasyonu destekler.

Tetkik 2: Eklem ultrasonografisi

Etiket: Eklem ultrasonografisi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ diz ekleminde belirgin efüzyon izlendi. | Klinik anlam: Aspirasyon gerektiren sıvı varlığını gösterir. | Sonuç yorumu: Aspirasyon gerektiren sıvı varlığını gösterir. | Sonuç başlığı: Eklem ultrasonografisi | Sonuç özeti: Sağ diz ekleminde belirgin efüzyon izlendi. | Yorum: Aspirasyon gerektiren sıvı varlığını gösterir. | Satırlar: Eklem ultrasonografisi / Sağ diz ekleminde belirgin efüzyon izlendi. // Aspirasyon gerektiren sıvı varlığını gösterir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-192 | Başlık: Eklem ultrasonografisi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Sağ diz ekleminde belirgin efüzyon izlendi. | Klinik anlam: Aspirasyon gerektiren sıvı varlığını gösterir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqds.public.blob.vercel-storage.com/192_septik_artrit_diz_efusyonu_usg.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqds.public.blob.vercel-storage.com/192_septik_artrit_diz_efusyonu_usg.webp | Alt text: Eklem ultrasonografisi - Sağ diz ekleminde belirgin efüzyon izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak
- B) İstirahat ve erken poliklinik kontrolüyle izlem planlamak
- C) Ağrı azalincaya kadar fizik tedavi egzersizi yaptırmak
- D) Kan kültürü sonucunu bekleyip eklem aspirasyonunu antibiyotik sonrasına bırakmak
- E) Oral antihistaminik vermek

Doğru Cevap: Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak

- A) Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak: Eklem aspirasyonu ve ampirik intravenöz antibiyotik septik artritte hem tanı hem de erken tedavi için doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.” ve “Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.
- B) İstirahat ve erken poliklinik kontrolüyle izlem planlamak: Vakadaki Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir ve Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır. Bu olguda “Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.” ve “Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Ağrı azalincaya kadar fizik tedavi egzersizi yaptırmak: Fizik tedavi akut enfekte eklemden ağrıyı ve hasarı artırabilir; önce enfeksiyon eklem aspirasyonu ve antibiyotikle kontrol edilmelidir. Bu olguda “Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.” ve “Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Kan kültürü sonucunu bekleyip eklem aspirasyonunu antibiyotik sonrasına bırakmak: Vakadaki Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir ve Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır. Bu olguda “Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.” ve “Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Oral antihistaminik vermek: Antihistaminik septik artritin enfeksiyöz mekanizmasını düzeltmez; bu seçenek alerjik semptomlara yöneliktir, eklem enfeksiyonuna değil. Bu olguda “Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.” ve “Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş ve tek dizde şişlik olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.” ve “Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.” birlikte okunduğunda Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak seçeneği öne çıkar; “CRP yüksek ve ultrasonografide eklem efüzyonu saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Ateş, akut ağrılı-şiş eklem, pasif hareketle şiddetli ağrı ve yüksek inflamatuvar belirteç septik artrit açısından acildir. Eklem aspirasyonu tanı için gereklidir; örnek alındıktan sonra ampirik intravenöz antibiyotik geciktirilmemelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.”, “Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.” ve “CRP yüksek ve ultrasonografide eklem efüzyonu saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Eklem aspirasyonu alıp ampirik intravenöz antibiyotik başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocuk ateşlidir ve diz üzerine basmak istememektedir.

Kanıt 2: Dizde sıcaklık, şişlik ve pasif hareketle şiddetli ağrı vardır.

Kanıt 3: CRP yüksek ve ultrasonografide eklem efüzyonu saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Septik artritte tedavi gecikmesi eklem kırıkdağında kalıcı hasara yol açabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 378: v196-new-378-yenidoganda-emme-azalması

Başlık: Yenidoğanda emme azalması

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Yenidoğan sepsisinde hipotermi, emme azalması ve dolaşım bozukluğuyla ampirik antibiyotik tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, emmede azalma, uykuya eğilim ve vücut sıcaklığında düşüklük nedeniyle getiriliyor. Ailesi son 24 saatte bebeği uyandırmakta zorlandığını, emme süresinin belirgin kısaldığını ve bez sayısının azaldığını belirtmektedir. Doğum öyküsünde annede uzamış membran rüptürü olduğu öğreniliyor. Evde ateş ölçülmemiştir.

Demografi: 13 günlük kız yenidoğan | Setting: Acil servis

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 176/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 35.7°C | Şok indeksi: 2,00 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik, hipotonik ve periferik perfüzyonu zayıftır.
- Ön fontanel normal bombelikte değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Lökopeni ve immatür nötrofil oranında artış saptandı. | Klinik anlam: Neonatal enfeksiyon açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Neonatal enfeksiyon açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Lökopeni ve immatür nötrofil oranında artış saptandı. | Yorum: Neonatal enfeksiyon açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Tam kan sayımı / Lökopeni ve immatür nötrofil oranında artış saptandı. / / Neonatal enfeksiyon açısından uyarıcıdır.

Tetkik 2: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Sistemik inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 46 mg/L / <5 mg/L / Sistemik inflamasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yenidoğanda en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak
- B) Termal stabilizasyon ve beslenme desteği sağlayıp antibiyotiği kültür sonucuna göre başlamak
- C) Seri vital izleme enfeksiyon tedavisini klinik kötüleşme olursa başlamak
- D) Aşı değerlendirmesi sonrası ayaktan izlem planlamak
- E) Oral antihistaminik vermek

Doğru Cevap: Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak

A) Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak: Kan kültürü sonrası ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi neonatal sepsis şüphesinde doğru acil yaklaşımdır. Vakadaki “Bebekte emme azalması ve letarji vardır.” ve “Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Termal stabilizasyon ve beslenme desteği sağlayıp antibiyotiği kültür sonucuna göre başlamak: Vakadaki Bebekte emme azalması ve letarji vardır ve Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte emme azalması ve letarji vardır.” ve “Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Seri vital izleme enfeksiyon tedavisini klinik kötüleşme olursa başlamak: Vakadaki Bebekte emme azalması ve letarji vardır ve Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte emme azalması ve letarji vardır.” ve “Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Aşı değerlendirmesi sonrası ayaktan izlem planlamak: Vakadaki Bebekte emme azalması ve letarji vardır ve Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte emme azalması ve letarji vardır.” ve “Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oral antihistaminik vermek: Antihistaminik enfeksiyöz sistemik tabloyu tedavi etmez; bu olguda alerjik döküntü değil neonatal sepsis bulguları ön plandadır. Bu olguda “Bebekte emme azalması ve letarji vardır.” ve “Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda emme azalması olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte emme azalması ve letarji vardır.” ve “Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak seçeneği öne çıkar; “Uzamış membran rüptürü enfeksiyon riskini artırmaktadır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda sepsis ateş yerine hipotermi, emme azalması, letarji ve dolaşım bozukluğu ile ortaya çıkabilir. Kültürler alınmalı ancak ampirik intravenöz antibiyotik ve hemodinamik destek tedavisi geciktirilmemelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte emme azalması ve letarji vardır.”, “Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.” ve “Uzamış membran rüptürü enfeksiyon riskini artırmaktadır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kan kültürü alıp ampirik intravenöz antibiyotik ve destek tedavisi başlamak en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte emme azalması ve letarji vardır.

Kanıt 2: Hipotermi, taşikardi ve uzamış kapiller dolum saptanmıştır.

Kanıt 3: Uzamış membran rüptürü enfeksiyon riskini artırmaktadır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağına yerine geçmez.

Exam Pearl: Yenidoğanda hipotermi de sepsis bulgusu olabilir; ateş olmaması sepsisi dışlamaz.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 379: v196-new-379-yenidogan-taramasinda-tiroid-bozuklugu

Başlık: Yenidoğan taramasında tiroid bozukluğu

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Konjenital hipotiroidiyi düşük serbest T4 ve yüksek TSH ile tanıyıp erken tedavinin önemini açıklayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, yenidoğan taramasında anormal tiroid sonucu nedeniyle ailesiyle birlikte getiriliyor. Ailesi bebeğin uykuya eğilimli olduğunu, emmesinin yavaş olduğunu ve son günlerde kabızlık başladığını belirtmektedir. Doğum miadında ve sorunsuz gerçekleşmiştir. Uzamış sarılık nedeniyle aile daha önce de polikliniğe başvurmuştur.

Demografi: 19 günlük kız bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 70/45 mmHg | Nabız: 124/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,77 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebekte hafif makroglossi, geniş ön fontanel ve uzamış sarılık vardır.
- Karın yumuşaktır, umbilikal herniye eğilim izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serbest T4

Etiket: Serbest T4 | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Tiroid hormon eksikliğini gösterir. | Sonuç yorumu: Tiroid hormon eksikliğini gösterir. | Sonuç başlığı: Serbest T4 | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Tiroid hormon eksikliğini gösterir. | Satırlar: Serbest T4 / 0.48 ng/dL / 0.9-2.3 ng/dL / Tiroid hormon eksikliğini gösterir.

Tetkik 2: TSH

Etiket: TSH | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Primer konjenital hipotiroidiyi destekler. | Sonuç yorumu: Primer konjenital hipotiroidiyi destekler. | Sonuç başlığı: TSH | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Primer konjenital hipotiroidiyi destekler. | Satırlar: TSH / 84 mIU/L / Primer konjenital hipotiroidiyi destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Konjenital hipotiroidi
- B) Neonatal hipertiroidi
- C) Konjenital adrenal hiperplazi
- D) Fenilketonüri
- E) Galaktozemi

Doğru Cevap: Konjenital hipotiroidi

A) Konjenital hipotiroidi: Konjenital hipotiroidi düşük serbest T4, yüksek TSH ve neonatal klinik bulgularla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.” ve “Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Neonatal hipertiroidi: Neonatal hipertiroidide serbest T4 yüksek ve TSH baskılı beklenir; bu Vakadaki düşük T4-yüksek TSH paterni primer hipotiroidiyi destekler. Bu olguda “Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.” ve “Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Konjenital hipotiroidi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Konjenital adrenal hiperplazi: Konjenital adrenal hiperplazi tuz kaybı, hiperkalemi veya virilizasyonla düşünülür; tiroid hormon paternini açıklamaz. Bu olguda “Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.” ve “Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Konjenital hipotiroidi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Fenilketonüri: Vakadaki Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur ve Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır. Bu olguda “Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.” ve “Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Konjenital hipotiroidi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Galaktozemi: Galaktozemi beslenme sonrası kusma, sarılık ve karaciğer yetmezliğiyle seyredir; primer tiroid hormon eksikliği değildir. Bu olguda “Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.” ve “Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Konjenital hipotiroidi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğan taramasında tiroid bozukluğu olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.” ve “Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.” birlikte okunduğunda Konjenital hipotiroidi seçeneği öne çıkar; “Serbest T4 düşük, TSH belirgin yüksektir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Düşük serbest T4 ve yüksek TSH primer konjenital hipotiroidiyi gösterir. Yenidoğan döneminde klinik bulgular silik olabilir; erken levotiroksin tedavisi nörogelişimsel hasarı önlemek için kritiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.”, “Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.” ve “Serbest T4 düşük, TSH belirgin yüksektir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Konjenital hipotiroidi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yenidoğan taramasında tiroid sonucu anormal bulunmuştur.

Kanıt 2: Bebekte emme yavaşlığı, kabızlık, makroglossi ve uzamış sarılık vardır.

Kanıt 3: Serbest T4 düşük, TSH belirgin yüksektir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Konjenital hipotiroidide tedavi gecikirse kalıcı nörogelişimsel etkilenme gelişebilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 380: v196-new-380-periorbital-odem-ve-kopuklu-idrar

Başlık: Periorbital ödem ve köpüklü idrar

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: Minimal değişiklik hastalığını çocukta nefrotik sendromun en sık nedeni olarak tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, sabahları belirginleşen göz kapağı şişliği ve köpüklü idrar nedeniyle getiriliyor. Yakınmalarının üst solunum yolu enfeksiyonundan yaklaşık bir hafta sonra başladığı, idrar renginde koyulaşma olmadığı ve ateşinin bulunmadığı öğreniliyor. Ailesi son günlerde çocuğun ayakkabılarının da dar geldiğini belirtmektedir.

Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Periorbital ödem ve hafif pretibial gode bırakan ödem vardır.
- Akciğer sesleri doğaldır.
- Döküntü, artrit veya karın ağrısı yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar protein/kreatinin oranı

Etiket: İdrar protein/kreatinin oranı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Nefrotik düzeyde yüksek saptandı. | Klinik anlam: Ağır proteinüriyi gösterir. | Sonuç yorumu: Ağır proteinüriyi gösterir. | Sonuç başlığı: İdrar protein/kreatinin oranı | Sonuç özeti: Nefrotik düzeyde yüksek saptandı. | Yorum: Ağır proteinüriyi gösterir. | Satırlar: İdrar protein/kreatinin oranı / Nefrotik düzeyde yüksek saptandı. // Ağır proteinüriyi gösterir.

Tetkik 2: Serum albümin

Etiket: Serum albümin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç yorumu: Nefrotik sendromu destekler. | Sonuç başlığı: Serum albümin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Nefrotik sendromu destekler. | Satırlar: Serum albümin / 2.0 g/dL / 3.5-5.0 g/dL / Nefrotik sendromu destekler.

Tetkik 3: Kompleman C3

Etiket: Kompleman C3 | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Kompleman tüketimli nefritik nedenleri geri plana iter. | Sonuç yorumu: Kompleman tüketimli nefritik nedenleri geri plana iter. | Sonuç başlığı: Kompleman C3 | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Kompleman tüketimli nefritik nedenleri geri plana iter. | Satırlar: Kompleman C3 / Normal saptandı. // Kompleman tüketimli nefritik nedenleri geri plana iter.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yaş grubunda bu tablonun en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Minimal değişiklik hastalığı
B) Alport sendromu
C) Membranoproliferatif glomerülonefrit
D) Akut interstisyel nefrit
E) Renal taş hastalığı

Doğru Cevap: Minimal değişiklik hastalığı

- A) Minimal değişiklik hastalığı: Minimal değişiklik hastalığı okul öncesi çocukta nefrotik sendrom, normal C3 ve normal kan basıncıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Alport sendromu: Alport sendromunda kalıtsal hematurî, işitme kaybı ve göz bulguları beklenir; saf nefrotik tablo tipik değildir. Bu olguda “Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Minimal değişiklik hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Membranoproliferatif glomerülonefrit: Membranoproliferatif glomerülonefritte kompleman düşüklüğü ve nefritik-nefrotik karışık tablo daha olasıdır. Bu olguda “Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Minimal değişiklik hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Akut interstisyel nefrit: Vakadaki Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır ve Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır. Bu olguda “Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Minimal değişiklik hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Renal taş hastalığı: Vakadaki Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır ve Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır. Bu olguda “Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Minimal değişiklik hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Periorbital ödem ve köpüklü idrar olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.” ve “Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Minimal değişiklik hastalığı seçeneği öne çıkar; “Kan basıncı ve kompleman C3 normaldir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Okul öncesi çocukta ödem, nefrotik düzeyde proteinüri, hipoalbüminemi, normal kan basıncı ve normal kompleman minimal değişiklik hastalığını düşündürür. Bu yaş grubunda nefrotik sendromun en sık nedeni minimal değişiklik hastalığıdır ve çoğu olgu steroide yanıt verir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.”, “Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.” ve “Kan basıncı ve kompleman C3 normaldir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Minimal değişiklik hastalığı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Çocukta periorbital ve pretibial ödem vardır.

Kanıt 2: Nefrotik düzeyde proteinüri ve hipoalbüminemi saptanmıştır.

Kanıt 3: Kan basıncı ve kompleman C3 normaldir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Çocukluk çağında nefrotik sendromun en sık nedeni minimal değişiklik hastalığıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 381: v196-new-381-purpura-ve-karin-agrisi

Başlık: Purpura ve karın ağrısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirmek.

Learning Target: IgA vaskülitinde palpabl purpura, karın ağrısı, artrit ve hematürinin birlikte değerlendirilmesi

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, bacaklarda kabarık mor döküntü, karın ağrısı ve diz ağrısı nedeniyle getiriliyor. Bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği, ardından kalça ve bacaklarda basmakla solmayan döküntüler başladığı öğreniliyor. Son iki gündür kramp tarzında karın ağrısı ve sağ dizde ağrı-şişlik gelişmiştir. Burun kanaması veya travma öyküsü yoktur.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Alt ekstremitelerde ve kalçalarda simetrik palpabl purpura vardır.
- Sağ dizde hafif efüzyon ve hassasiyet saptanır.
- Batın muayenesinde yaygın olmayan hassasiyet vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Trombositopenik purpurayı geri plana iter. | Sonuç yorumu: Trombositopenik purpurayı geri plana iter. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Trombositopenik purpurayı geri plana iter. | Satırlar: Trombosit sayısı / 282000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Trombositopenik purpurayı geri plana iter.

Tetkik 2: İdrar tahlili

Etiket: İdrar tahlili | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Mikroskopik hematüri saptandı. | Klinik anlam: Renal tutulum olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Renal tutulum olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: İdrar tahlili | Sonuç özeti: Mikroskopik hematüri saptandı. | Yorum: Renal tutulum olasılığını destekler. | Satırlar: İdrar tahlili / Mikroskopik hematüri saptandı. // Renal tutulum olasılığını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) IgA vaskülit
B) İmmün trombositopeni
C) Kızamık
D) İlaç ürtikeri
E) Akut lenfadenit

Doğru Cevap: IgA vaskülit

- A) IgA vaskülit: IgA vaskülit palpabl purpura, karın ağrısı, artrit ve hematüri kombinasyonu en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır." ve "Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) İmmün trombositopeni: Vakadaki Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır ve Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir. Bu olguda "Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır." ve "Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Kızamık: Vakadaki Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır ve Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir. Bu olguda "Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır." ve "Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) İlaç ürtikeri: Vakadaki Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır ve Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir. Bu olguda "Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır." ve "Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Akut lenfadenit: Akut lenfadenit bölgesel lenf nodu enfeksiyonudur; yaygın palpabl purpura ve renal bulgu yapmaz. Bu olguda "Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır." ve "Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından IgA vaskülit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Purpura ve karın ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır." ve "Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda IgA vaskülit seçeneği öne çıkar; "Trombosit normal iken idrarda mikroskopik hematüri saptanmıştır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen palpabl purpura, karın ağrısı, artrit ve hematüri IgA vaskülitini düşündürür. Normal trombosit sayısı, döküntünün trombositopeniye bağlı olmadığını gösterir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır.", "Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir." ve "Trombosit normal iken idrarda mikroskopik hematüri saptanmıştır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle IgA vaskülit en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Alt ekstremitelerde ve kalçalarda palpabl purpura vardır.

Kanıt 2: Karın ağrısı ve diz artrit eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Trombosit normal iken idrarda mikroskopik hematüri saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: IgA vaskülitinde purpura trombositopeniye bağlı değildir; böbrek izlemi önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 382: v196-new-382-bes-gunu-asan-ates

Başlık: Beş günü aşan ateş

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Kawasaki hastalığında mukokutanöz bulgularla IVIG tedavisinin koroner komplikasyonu önlediğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, altı gündür süren ateş, gözlerde kızarıklık ve döküntü nedeniyle getiriliyor. Aile, ateşin antibiyotik ve ateş düşürücülere rağmen tam düşmediğini, son günlerde dudaklarda çatlama, dilde kızarıklık ve el-ayaklarda şişlik geliştiğini belirtmektedir. Öksürük veya pürülan göz akıntısı belirgin değildir.

Demografi: 3 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bilateral nonpürülan konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudaklar, gövdede polimorf döküntü ve el-ayaklarda ödem vardır.
- Sol servikal bölgede yaklaşık 2 cm hassas olmayan lenf nodu palpe edilir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Sistemik inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Sistemik inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 86 mg/L / <5 mg/L / Sistemik inflamasyonu destekler.

Tetkik 2: Ekokardiyografi

Etiket: Ekokardiyografi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Koroner arter çapları başlangıç değerlendirmesi için ölçüldü; belirgin anevrizma saptanmadı. | Klinik anlam: Koroner izlem gereklidir. | Sonuç yorumu: Koroner izlem gereklidir. | Sonuç başlığı: Ekokardiyografi | Sonuç özeti: Koroner arter çapları başlangıç değerlendirmesi için ölçüldü; belirgin anevrizma saptanmadı. | Yorum: Koroner izlem gereklidir. | Satırlar: Ekokardiyografi / Koroner arter çapları başlangıç değerlendirmesi için ölçüldü; belirgin anevrizma saptanmadı. / / Koroner izlem gereklidir.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-193 | Başlık: Ekokardiyografi | Modalite: ultrasound | Bulgu: Koroner arter çapları başlangıç değerlendirmesi için ölçüldü; belirgin anevrizma saptanmadı. | Klinik anlam: Koroner izlem gereklidir. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/193_kawasaki_koroner_izlem_eko.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsds.public.blob.vercel-storage.com/193_kawasaki_koroner_izlem_eko.webp | Alt text: Ekokardiyografi - Koroner arter çapları başlangıç değerlendirmesi için ölçüldü; belirgin anevrizma saptanmadı. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta koroner arter komplikasyonu riskini azaltmak için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi
B) Ekokardiyografi sonucunu bekleyerek intravenöz immünglobulin kararını ertelemek
C) Antifungal tedaviyle mukokutanöz bulguları izlemek
D) Acil apendektomi
E) Antihistaminik tedavi

Doğru Cevap: İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi

A) İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi: İntravenöz immünglobulin ve aspirin Kawasaki hastalığında inflamasyonu kontrol ederek koroner komplikasyon riskini azaltır. Vakadaki "Ateş altı gündür sürmektedir." ve "Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

B) Ekokardiyografi sonucunu bekleyerek intravenöz immünglobulin kararını ertelemek: Vakadaki Ateş altı gündür sürmektedir ve Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır. Bu olguda "Ateş altı gündür sürmektedir." ve "Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Antifungal tedaviyle mukokutanöz bulguları izlemek: Vakadaki Ateş altı gündür sürmektedir ve Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır. Bu olguda "Ateş altı gündür sürmektedir." ve "Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Acil apendektomi: Apendektomi bu sistemik vaskülit tablosuyla ilişkili değildir; olguda akut batin değil mukokutanöz vaskülit bulguları vardır. Bu olguda "Ateş altı gündür sürmektedir." ve "Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Antihistaminik tedavi: Vakadaki Ateş altı gündür sürmektedir ve Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır. Bu olguda "Ateş altı gündür sürmektedir." ve "Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır." ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Beş günü aşan ateş olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Ateş altı gündür sürmektedir." ve "Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır." birlikte okunduğunda İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi seçeneği öne çıkar; "Döküntü ve servikal lenfadenopati eşlik etmektedir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Beş günü aşan ateş, bilateral nonpürülan konjonktivit, oral mukoza değişiklikleri, ekstremitte bulguları, döküntü ve servikal lenfadenopati Kawasaki hastalığını düşündürür. Erken IVIG tedavisi koroner arter anevrizması riskini azaltır; aspirin inflamasyon ve trombotik risk yönetiminde kullanılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ateş altı gündür sürmektedir.", "Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır." ve "Döküntü ve servikal lenfadenopati eşlik etmektedir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz immünglobulin ve aspirin tedavisi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Ateş altı gündür sürmektedir.

Kanıt 2: Konjonktivit, çilek dili, çatlamış dudak ve ekstremitte ödemi vardır.

Kanıt 3: Döküntü ve servikal lenfadenopati eşlik etmektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Kawasaki hastalığında IVIG ilk 10 gün içinde verildiğinde koroner anevrizma riskini azaltır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 383: v196-new-383-yenidoganda-kusma-ve-ambigus-genital-yapi

Başlık: Yenidoğanda kusma ve ambigus genital yapı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Klasik 21-hidroksilaz eksikliğini tuz kaybı, virilizasyon ve yüksek 17-hidroksiprogesteronla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, kusma, kilo kaybı, halsizlik ve dış genital yapı farklılığı nedeniyle getiriliyor. Doğumdan sonra ilk günlerde emmesinin fena olmadığı ancak son iki gündür kusma, beslenememe ve uykuya eğilim geliştiği öğreniliyor. Aile bebeğin bezinde idrar miktarının azaldığını belirtmektedir. Yenidoğan taraması sonucu henüz aileye ulaşmamıştır.

Demografi: 10 günlük kız yenidoğan | Setting: Yenidoğan değerlendirme

Vital Bulgular

Kan basıncı: 68/38 mmHg | Nabız: 172/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.7°C | Şok indeksi: 2,53 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek dehidrate ve halsizdir.
- Dış genital yapıda klitoromegali ve labial füzyon izlenir.
- Kapiller dolum uzamıştır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Tuz kaybını destekler. | Sonuç yorumu: Tuz kaybını destekler. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Tuz kaybını destekler. | Satırlar: Serum sodyum / 123 mmol/L / 135-145 mmol/L / Tuz kaybını destekler.

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: Mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum potasyum / 6.5 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L / Mineralokortikoid eksikliğini destekler.

Tetkik 3: 17-hidroksiprogesteron

Etiket: 17-hidroksiprogesteron | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: 21-hidroksilaz eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: 21-hidroksilaz eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: 17-hidroksiprogesteron | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: 21-hidroksilaz eksikliğini destekler. | Satırlar: 17-hidroksiprogesteron / Belirgin yüksek saptandı. / / 21-hidroksilaz eksikliğini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi
B) Konjenital hipotiroidi
C) Turner sendromu
D) Santral diyabetes insipidus
E) Hipofosfatazik raşitizm

Doğru Cevap: 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi

A) 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi: 21-hidroksilaz eksikliği virilizasyon, tuz kaybı, hiponatremi, hiperkalemi ve yüksek 17-hidroksiprogesteronla en uyumludur. Vakadaki "Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Konjenital hipotiroidi: Konjenital hipotiroidi kabızlık, uzamış sarılık ve yüksek TSH ile seyreder; virilizasyon ve hiperkalemi yapmaz. Bu olguda "Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler." ipuçları tanısal karar açısından 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Turner sendromu: Turner sendromunda kısa boy ve gonadal disgenezi beklenir; tuz kaybettiren kriz ve virilizasyon tipik değildir. Bu olguda "Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler." ipuçları tanısal karar açısından 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Santral diyabetes insipidus: Santral diyabetes insipidus poliüri ve hipernatremi yapar; hiperkalemi ve virilizasyon açıklanamaz. Bu olguda "Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler." ipuçları tanısal karar açısından 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hipofosfatazik raşitizm: Hipofosfatazik raşitizm kemik mineralizasyon bozukluğudur; yenidoğan tuz kaybı ve ambigus genital yapı yapmaz. Bu olguda "Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler." ipuçları tanısal karar açısından 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğanda kusma ve ambigus genital yapı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır." ve "Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler." birlikte okunduğunda 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi seçeneği öne çıkar; "17-hidroksiprogesteron düzeyi belirgin yüksektir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kız yenidoğanda virilizasyon, kusma, dehidratasyon, hiponatremi, hiperkalemi ve yüksek 17-hidroksiprogesteron tuz kaybettiren klasik 21-hidroksilaz eksikliğini düşündürür. Kortizol ve aldosteron sentezi azalırken androjen öncülleri artar. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır.", "Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler." ve "17-hidroksiprogesteron düzeyi belirgin yüksektir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle 21-hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi en tutarlı yanıtır.

Kanıt 1: Dış genital yapıda virilizasyon bulguları vardır.

Kanıt 2: Hiponatremi ve hiperkalemi tuz kaybettiren adrenal yetmezliği destekler.

Kanıt 3: 17-hidroksiprogesteron düzeyi belirgin yüksektir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: 21-hidroksilaz eksikliğinde kortizol ve aldosteron azalır, adrenal androjenler artar.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 384: v196-new-384-tekrarlayan-oksuruk-ve-yagli-diski

Başlık: Tekrarlayan öksürük ve yağlı dışkı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Kistik fibrozisi tekrarlayan solunum enfeksiyonu, pankreatik yetmezlik ve yüksek ter klorürüyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, kilo alamama ve kötü kokulu yağlı dışkılama nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun iştahının iyi olmasına rağmen kilo alamadığını, dışkısının hacimli ve yağlı olduğunu, son bir yılda birkaç kez antibiyotik gerektiren öksürük atağı geçirdiğini belirtmektedir. Yenidoğan döneminde mekonyum çıkışının geciktiği öğreniliyor.

Demografi: 2 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Çocuk zayıf görünümündedir.
- Boy ve kilo persentilleri düşüktür.
- Akciğerlerde bilateral kaba raller duyulur.
- Parmaklarda hafif çomaklaşma başlangıcı izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Ter klorür testi

Etiket: Ter klorür testi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kistik fibrozisi destekler. | Sonuç yorumu: Kistik fibrozisi destekler. | Sonuç başlığı: Ter klorür testi | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kistik fibrozisi destekler. | Satırlar: Ter klorür testi / 84 mmol/L / <30 mmol/L genellikle normal / Kistik fibrozisi destekler.

Tetkik 2: Dışkıda elastaz

Etiket: Dışkıda elastaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Pankreatik ekzokrin yetmezliği destekler. | Sonuç yorumu: Pankreatik ekzokrin yetmezliği destekler. | Sonuç başlığı: Dışkıda elastaz | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Pankreatik ekzokrin yetmezliği destekler. | Satırlar: Dışkıda elastaz / Düşük saptandı. / / Pankreatik ekzokrin yetmezliği destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kistik fibrozis
B) Çölyak hastalığı
C) Laktoz intoleransı
D) Primer siliyer diskinezi
E) Selektif IgA eksikliği

Doğru Cevap: Kistik fibrozis

- A) Kistik fibrozis: Kistik fibrozis yüksek ter klorürü, tekrarlayan solunum enfeksiyonu ve pankreatik yetmezlik bulgularıyla en uyumludur. Vakadaki "Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır." ve "Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Çölyak hastalığı: Çölyak hastalığı malabsorpsiyon yapabilir ancak yüksek ter klorürü ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonu tipik değildir. Bu olguda "Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır." ve "Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Kistik fibrozis seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Laktoz intoleransı: Laktoz intoleransı süt ürünleri sonrası osmotik semptomlar yapar; pankreatik yetmezlik ve yüksek ter klorürü beklenmez. Bu olguda "Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır." ve "Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Kistik fibrozis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Primer siliyer diskinezi: Primer siliyer diskinezi tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyon yapabilir ancak yağlı dışkı ve yüksek ter klorürü kistik fibrozisi daha güçlü destekler. Bu olguda "Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır." ve "Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Kistik fibrozis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Selektif IgA eksikliği: Selektif IgA eksikliği enfeksiyon ve otoimmüniteyle ilişkili olabilir ancak CFTR ilişkili ter klorür yüksekliğini açıklamaz. Bu olguda "Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır." ve "Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir." ipuçları tanısal karar açısından Kistik fibrozis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tekrarlayan öksürük ve yağlı dışkı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır." ve "Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir." birlikte okunduğunda Kistik fibrozis seçeneği öne çıkar; "Ter klorür testi belirgin yüksektir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonlar, malabsorptif yağlı dışkı, gelişme geriliği, yüksek ter klorürü ve pankreatik ekzokrin yetmezliği kistik fibrozisi düşündürür. CFTR bozukluğu koyu sekresyonlar ve klorür taşınma bozukluğu oluşturur. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır.", "Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir." ve "Ter klorür testi belirgin yüksektir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Kistik fibrozis en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları vardır.

Kanıt 2: Yağlı-kötü kokulu dışkı ve kilo alamama tariflenmiştir.

Kanıt 3: Ter klorür testi belirgin yüksektir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Kistik fibrozis tanısında ter klorür yüksekliği klasik bulgudur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 385: v196-new-385-uzamis-sarilik-ve-acik-renk-diski

Başlık: Uzamış sarılık ve açık renk dışkı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Biliyer atrezide direkt hiperbilirubinemi, akolik dışkı ve erken cerrahi yönlendirmeyi tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, doğumdan beri süren sarılık, koyu idrar ve dışkı renginin açılması nedeniyle getiriliyor. Ailesi sarılığın hiç tam düzelmediğini, son iki haftadır dışkının kil rengine döndüğünü ve idrarın bezde koyu sarı-kahverengi leke bıraktığını belirtmektedir. Beslenmesi kısmen korunmuştur ancak kilo alımı beklenenden düşüktür.

Demografi: 5 haftalık kız bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Skleralar ikteriktir.
- Karaciğer sağ kosta ark altında 3 cm ele gelir ve sertçe hissedilir.
- Dışkı örneği açık renklidir.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Direkt bilirubin

Etiket: Direkt bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kolestatik sarılığı destekler. | Sonuç yorumu: Kolestatik sarılığı destekler. | Sonuç başlığı: Direkt bilirubin | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kolestatik sarılığı destekler. | Satırlar: Direkt bilirubin / 5.4 mg/dL / <0.3 mg/dL / Kolestatik sarılığı destekler.

Tetkik 2: Gama-glutamil transferaz

Etiket: Gama-glutamil transferaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Obstrüktif kolestazi destekler. | Sonuç yorumu: Obstrüktif kolestazi destekler. | Sonuç başlığı: Gama-glutamil transferaz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Obstrüktif kolestazi destekler. | Satırlar: Gama-glutamil transferaz / Yüksek saptandı. // Obstrüktif kolestazi destekler.

Tetkik 3: Hepatobiliyer sintigrafi

Etiket: Hepatobiliyer sintigrafi | Tip: lab | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Barsaklara safra geçişi izlenmedi. | Klinik anlam: Ekstrahepatik safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Ekstrahepatik safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: Hepatobiliyer sintigrafi | Sonuç özeti: Barsaklara safra geçişi izlenmedi. | Yorum: Ekstrahepatik safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | Satırlar: Hepatobiliyer sintigrafi / Barsaklara safra geçişi izlenmedi. // Ekstrahepatik safra yolu obstrüksiyonunu destekler.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-194 | Başlık: Hepatobiliyer sintigrafi | Modalite: xray | Bulgu: Barsaklara safra geçişi izlenmedi. | Klinik anlam: Ekstrahepatik safra yolu obstrüksiyonunu destekler. | URL: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/194_biliyer_atrezi_hepatobiliyer_sintigrafi.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzxiqtqdsd.public.blob.vercel-storage.com/194_biliyer_atrezi_hepatobiliyer_sintigrafi.webp | Alt text: Hepatobiliyer sintigrafi - Barsaklara safra geçişi izlenmedi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Biliyer atrezi
B) Fizyolojik yenidoğan sarılığı
C) Anne sütü sarılığı
D) Gilbert sendromu
E) ABO uyumsuzluğuna bağlı hemoliz

Doğru Cevap: Biliyer atrezi

A) Biliyer atrezi: Biliyer atrezi uzamış direkt hiperbilirubinemi, akolik dışkı ve safra geçişinin olmamasıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.” ve “Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

B) Fizyolojik yenidoğan sarılığı: Vakadaki Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir ve Dışkı açık renkli ve idrar koyudur. Bu olguda “Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.” ve “Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.” ipuçları tanısal karar açısından Biliyer atrezi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Anne sütü sarılığı: Anne sütü sarılığı genellikle indirekt hiperbilirubinemiyle seyredir; koyu idrar ve akolik dışkı beklenmez. Bu olguda “Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.” ve “Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.” ipuçları tanısal karar açısından Biliyer atrezi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Gilbert sendromu: Gilbert sendromu hafif indirekt hiperbilirubinemi yapar; bebekte kolestaz bulgularını açıklamaz. Bu olguda “Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.” ve “Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.” ipuçları tanısal karar açısından Biliyer atrezi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) ABO uyumsuzluğuna bağlı hemoliz: ABO hemolizi indirekt bilirubin artışı yapar; direkt bilirubin yüksekliği ve akolik dışkı tipik değildir. Bu olguda “Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.” ve “Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.” ipuçları tanısal karar açısından Biliyer atrezi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzamış sarılık ve açık renk dışkı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.” ve “Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.” birlikte okunduğunda Biliyer atrezi seçeneği öne çıkar; “Direkt bilirubin yüksek ve sintigrafide barsaklara safra geçişi yoktur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Uzamış sarılıktaki direkt bilirubin yüksekliği, akolik dışkı, koyu idrar, hepatomegali ve barsağa safra geçişinin olmaması biliyer atreziyi düşündürür. Erken tanı ve Kasai portoenterostomisi için hızlı cerrahi yönlendirme prognoz açısından kritiktir. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.”, “Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.” ve “Direkt bilirubin yüksek ve sintigrafide barsaklara safra geçişi yoktur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Biliyer atrezi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Sarılık 5 haftalık dönemde devam etmektedir.

Kanıt 2: Dışkı açık renkli ve idrar koyudur.

Kanıt 3: Direkt bilirubin yüksek ve sintigrafide barsaklara safra geçişi yoktur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Yenidoğanda akolik dışkı ve direkt hiperbilirubinemi fizyolojik kabul edilmez.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 386: v196-new-386-gec-yurume-ve-bacak-egriligi

Başlık: Geç yürüme ve bacak eğriliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: D vitamini eksikliği raşitizmde mineralizasyon bozukluğu bulgularını klinik ve laboratuvarla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, geç yürüme, bacaklarda eğrilik ve el bileklerinde genişleme nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun çoğunlukla kapalı ortamda kaldığını, düzenli D vitamini desteği kullanmadığını ve süt ürünleri tüketiminin sınırlı olduğunu belirtmektedir. Son aylarda ayağa kalkarken zorlanma ve çabuk yorulma dikkat çekmiştir.

Demografi: 18 aylık erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Genu varum, el bileklerinde genişleme ve kostokondral bileşkelerde belirginleşme vardır.
- Kas tonusu hafif azalmıştır.
- Diş çıkışı yaşitlarına göre gecikmiştir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum fosfor

Etiket: Serum fosfor | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Raşitizmle uyumludur. | Sonuç yorumu: Raşitizmle uyumludur. | Sonuç başlığı: Serum fosfor | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Raşitizmle uyumludur. | Satırlar: Serum fosfor / 2.7 mg/dL / 4.0-7.0 mg/dL / Raşitizmle uyumludur.

Tetkik 2: Alkalen fosfataz

Etiket: Alkalen fosfataz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Artmış osteoblast aktivitesini gösterir. | Sonuç yorumu: Artmış osteoblast aktivitesini gösterir. | Sonuç başlığı: Alkalen fosfataz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Artmış osteoblast aktivitesini gösterir. | Satırlar: Alkalen fosfataz / 980 U/L / / Artmış osteoblast aktivitesini gösterir.

Tetkik 3: 25-OH D vitamini

Etiket: 25-OH D vitamini | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: D vitamini eksikliğini destekler. | Sonuç yorumu: D vitamini eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: 25-OH D vitamini | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: D vitamini eksikliğini destekler. | Satırlar: 25-OH D vitamini / Düşük saptandı. / / D vitamini eksikliğini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) D vitamini eksikliği raşitizmi
B) Skorbüt
C) Akondroplazi
D) Osteopetrozis
E) Hipofiz gigantizmi

Doğru Cevap: D vitamini eksikliği raşitizmi

A) D vitamini eksikliği raşitizmi: D vitamini eksikliği raşitizmi klinik kemik deformiteleri ve düşük D vitamini-yüksek alkalen fosfataz paterniyle en uyumludur. Vakadaki "Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır." ve "D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerçekleşir.

B) Skorbüt: Skorbüt C vitamini eksikliğine bağlı kanama, diş eti bulguları ve kemik ağrısıyla seyreder; bu Laboratuvar bulgusu tipik değildir. Bu olguda "Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır." ve "D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır." ipuçları tanısal karar açısından D vitamini eksikliği raşitizmi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Akondroplazi: Akondroplazi genetik kısa ekstremiteli cücelik yapar; D vitamini düşüklüğü ve yüksek alkalen fosfatazla açıklanmaz. Bu olguda "Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır." ve "D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır." ipuçları tanısal karar açısından D vitamini eksikliği raşitizmi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Osteopetrozis: Osteopetrozis kemik yoğunluğunda artış ve kemik iliği yetmezliğiyle ilişkilidir; klasik raşitik deformite değildir. Bu olguda "Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır." ve "D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır." ipuçları tanısal karar açısından D vitamini eksikliği raşitizmi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Hipofiz gigantizmi: Vakadaki Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır ve D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır. Bu olguda "Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır." ve "D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır." ipuçları tanısal karar açısından D vitamini eksikliği raşitizmi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Geç yürüme ve bacak eğriliği olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır." ve "D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır." birlikte okunduğunda D vitamini eksikliği raşitizmi seçeneği öne çıkar; "Fosfor düşük, alkalen fosfataz yüksek ve 25-OH D vitamini düşüktür." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: D vitamini eksikliği büyüme plağında mineralizasyon bozukluğuna yol açar. Genu varum, el bileği genişlemesi, raşitik rozary, düşük fosfor, yüksek alkalen fosfataz ve düşük 25-OH D vitamini raşitizmle uyumludur. Bu olguda kararın temel ayırımı, "Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır.", "D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır." ve "Fosfor düşük, alkalen fosfataz yüksek ve 25-OH D vitamini düşüktür." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle D vitamini eksikliği raşitizmi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocukta bacak eğriliği ve el bileği genişlemesi vardır.

Kanıt 2: D vitamini desteği kullanılmamış ve güneş maruziyeti azdır.

Kanıt 3: Fosfor düşük, alkalen fosfataz yüksek ve 25-OH D vitamini düşüktür.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Raşitizmde büyüme plaklarında mineralizasyon bozulur ve alkalen fosfataz genellikle yükselir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 387: v196-new-387-uzayan-oksuruk-nobetleri

Başlık: Uzayan öksürük nöbetleri

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: Boğmacada paroksizmal öksürük ve makrolid tedavisini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, haftalardır süren nöbetler halinde öksürük, öksürük sonrası kusma ve morarma atakları nedeniyle getiriliyor. Aşılarının henüz tamamlanmadığı, evde iki haftadır öksüren bir erişkinle yakın teması olduğu öğreniliyor. Ateşi belirgin değildir. Aile, bebeğin öksürük nöbetleri arasında görece iyi olduğunu ancak nöbet sırasında nefes alamıyor gibi görüldüğünü belirtmektedir.

Demografi: 3 aylık erkek bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebek muayene sırasında iyi görünmektedir.
- Öksürük nöbeti sırasında ardışık öksürükler ve kısa apne-morarma tariflenir.
- Akciğer oskültasyonu nöbet dışında belirgin patoloji göstermez.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Nazofarengeal PCR

Etiket: Nazofarengeal PCR | Tip: lab | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Bordetella pertussis pozitif saptandı. | Klinik anlam: Boğmaca tanısını destekler. | Sonuç yorumu: Boğmaca tanısını destekler. | Sonuç başlığı: Nazofarengeal PCR | Sonuç özeti: Bordetella pertussis pozitif saptandı. | Yorum: Boğmaca tanısını destekler. | Satırlar: Nazofarengeal PCR / Bordetella pertussis pozitif saptandı. // Boğmaca tanısını destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte uygun etken hedefli tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Azitromisin tedavisi
B) Acyclovir tedavisi
C) Amfoterisin B tedavisi
D) Albendazol tedavisi
E) Oseltamivir tedavisi

Doğru Cevap: Azitromisin tedavisi

A) Azitromisin tedavisi: Azitromisin Bordetella pertussis enfeksiyonunda uygun makrolid tedavisidir. Vakadaki “Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

B) Acyclovir tedavisi: Vakadaki Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır ve Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır. Bu olguda “Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Azitromisin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Amfoterisin B tedavisi: Vakadaki Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır ve Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır. Bu olguda “Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Azitromisin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Albendazol tedavisi: Vakadaki Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır ve Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır. Bu olguda “Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Azitromisin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Oseltamivir tedavisi: Vakadaki Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır ve Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır. Bu olguda “Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Azitromisin tedavisi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Uzayan öksürük nöbetleri olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.” ve “Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.” birlikte okunduğunda Azitromisin tedavisi seçeneği öne çıkar; “Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis için pozitifdir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Paroksizmal öksürük, öksürük sonrası kusma, apne-morarma atakları ve Bordetella pertussis PCR pozitifliği boğmacayı düşündürür. Makrolid tedavisi bulaştırıcılığı azaltır ve erken dönemde klinik seyri etkileyebilir; temaslı profilaksisi de önemlidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.”, “Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.” ve “Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis için pozitifdir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Azitromisin tedavisi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte paroksizmal öksürük ve öksürük sonrası kusma vardır.

Kanıt 2: Aşıları tamamlanmamış ve öksüren erişkin teması vardır.

Kanıt 3: Nazofarengeal PCR Bordetella pertussis için pozitifdir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Boğmacada tedavi ve temas profilaksisinde makrolidler kullanılır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 388: v196-new-388-solukluk-morarma-ve-kemik-agrisi

Başlık: Solukluk, morarma ve kemik ağrısı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Akut lenfoblastik lösemiye kemik iliği yetmezliği, organomegali ve blast varlığıyla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, halsizlik, kolay morarma, burun kanaması ve bacak ağrıları nedeniyle getiriliyor. Son bir ayda iştahsızlık, gece terlemesi, aralıklı ateş ve yürümek istememe geliştiği öğreniliyor. Ailesi çocuğun oyun sırasında çabuk yorulduğunu ve bacak ağrısı nedeniyle kucağa alınmak istediğini belirtmektedir.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Çocuk soluk görünmektedir.
- Bacaklarda ekimozlar, servikal lenfadenopati ve hafif hepatosplenomegali vardır.
- Kemik palpasyonunda özellikle tibial bölgelerde hassasiyet tarifler.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Anemiyi gösterir. | Sonuç yorumu: Anemiyi gösterir. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Anemiyi gösterir. | Satırlar: Hemoglobin / 7.4 g/dL // Anemiyi gösterir.

Tetkik 2: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Trombositopeniyi gösterir. | Sonuç yorumu: Trombositopeniyi gösterir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Trombositopeniyi gösterir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 34000 /mm³ / 150000-450000 /mm³ / Trombositopeniyi gösterir.

Tetkik 3: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Patoloji | Özet: Blast hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Akut lösemi açısından uyarıcıdır. | Sonuç yorumu: Akut lösemi açısından uyarıcıdır. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Blast hücreleri izlendi. | Yorum: Akut lösemi açısından uyarıcıdır. | Satırlar: Periferik yayma / Blast hücreleri izlendi. // Akut lösemi açısından uyarıcıdır.

Görseller

Görsel 1: ID: visual-195 | Başlık: Periferik yayma | Modalite: microscopy | Bulgu: Blast hücreleri izlendi. | Klinik anlam: Akut lösemi açısından uyarıcıdır. | URL: https://iukbtlkzixictqsds.public.blob.vercel-storage.com/195_akut_lenfoblastik_losemi_blast_yayma.webp | Thumbnail: https://iukbtlkzixictqsds.public.blob.vercel-storage.com/195_akut_lenfoblastik_losemi_blast_yayma.webp | Alt text: Periferik yayma - Blast hücreleri izlendi. | Asset durumu: vercel-blob-ready

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut lenfoblastik lösemi
B) Demir eksikliği anemisi
C) İmmün trombositopeni
D) Talassemi taşıyıcılığı
E) Vitamin D eksikliği

Doğru Cevap: Akut lenfoblastik lösemi

- A) Akut lenfoblastik lösemi: Akut lenfoblastik lösemi blast varlığı, çoklu seri sitopenisi, kemik ağrısı ve organomegaliyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir.” ve “Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.
- B) Demir eksikliği anemisi: Vakadaki Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir ve Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut lenfoblastik lösemi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) İmmün trombositopeni: İmmün trombositopeni genellikle izole trombositopeni yapar; anemi, organomegali ve blast beklenmez. Bu olguda “Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir.” ve “Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut lenfoblastik lösemi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Talassemi taşıyıcılığı: Talassemi taşıyıcılığı mikrositozla seyredir; akut blastlı kemik iliği yetmezliği tablosunu açıklamaz. Bu olguda “Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir.” ve “Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut lenfoblastik lösemi seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Vitamin D eksikliği: Vakadaki Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir ve Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır. Bu olguda “Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir.” ve “Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.” ipuçları tanısal karar açısından Akut lenfoblastik lösemi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Solukluk, morarma ve kemik ağrısı olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir.” ve “Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.” birlikte okunduğunda Akut lenfoblastik lösemi seçeneği öne çıkar; “Periferik yaymada blast hücreleri izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Çocukta solukluk, ekimoz, kemik ağrısı, lenfadenopati, hepatosplenomegali, anemi, trombositopeni ve periferik yaymada blast varlığı akut lenfoblastik lösemiye düşündürür. Tanı kemik iliği incelemesi ve immünohistokimya ile doğrulanır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir.”, “Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.” ve “Periferik yaymada blast hücreleri izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Akut lenfoblastik lösemi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Solukluk, ekimoz ve burun kanaması kemik iliği yetmezliğini düşündürmektedir.

Kanıt 2: Kemik ağrısı, lenfadenopati ve hepatosplenomegali vardır.

Kanıt 3: Periferik yaymada blast hücreleri izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Çocukluk çağının en sık malignitesi akut lenfoblastik lösemidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 389: v196-new-389-aksamlari-artan-aglama

Başlık: Akşamları artan ağlama

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik tabloya uygun tedavi yaklaşımını seçme.

Learning Target: İnfantil kolikte alarm bulgusu yoksa aileyi rahatlatma ve destekleyici yaklaşımı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, özellikle akşam saatlerinde saatler süren ağlama atakları nedeniyle getiriliyor. Ailesi bebeğin gün içinde beslendiğini, kilo aldığını, ateşinin olmadığını ve ağlama ataklarının genellikle aynı saatlerde başladığını anlatmaktadır. Kusması safra içerikli değildir, dışkısında kan yoktur ve emme sonrası morarma olmamaktadır.

Demografi: 7 haftalık erkek bebek | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebek muayene sırasında sakindir.
- Tartı alımı yaşına uygundur.
- Batın yumuşaktır, defans yoktur.
- Dehidratasyon, travma, ateş veya nörolojik anormallik saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Bu bölümde kayıtlı tetkik verisi yok.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri
B) Acil karın ameliyatı
C) Geniş spektrumlu antibiyotik başlamak
D) Gastroözofageal reflü için ampirik proton pompa inhibitörü başlamak
E) Kontrol tedavisi olarak sedatif tedavi başlamak

Doğru Cevap: Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri

A) Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri: Aileyi bilgilendirme ve destekleyici öneriler alarm bulgusu olmayan infantil kolikte uygun yaklaşımdır. Vakadaki “Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.” ve “Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereksizdir.

B) Acil karın ameliyatı: Acil cerrahi normal muayeneli ve iyi büyüyen bebekte gereksizdir; alarm bulgusu yokken tablo infantil kolikle uyumludur. Bu olguda “Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.” ve “Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Geniş spektrumlu antibiyotik başlamak: Antibiyotik enfeksiyon bulgusu olmayan kolik tablosunu tedavi etmez; ateş, toksik görünüm veya fokal enfeksiyon bulgusu verilmemiştir. Bu olguda “Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.” ve “Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Gastroözofageal reflü için ampirik proton pompa inhibitörü başlamak: Vakadaki Bebek yaşına uygun kilo almaktadır ve Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur. Bu olguda “Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.” ve “Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Kontrol tedavisi olarak sedatif tedavi başlamak: Vakadaki Bebek yaşına uygun kilo almaktadır ve Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur. Bu olguda “Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.” ve “Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.” ipuçları tedavi önceliği açısından Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Akşamları artan ağlama olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.” ve “Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.” birlikte okunduğunda Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri seçeneği öne çıkar; “Ağlama atakları özellikle akşamları tekrarlayan özellik göstermektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: İyi büyüyen, ateşsiz, muayenesi normal infantta tekrarlayan akşam ağlama atakları infantil kolikle uyumludur. Alarm bulgusu yoksa gereksiz tetkik ve ilaçtan kaçınılmalı; aileye durumun iyi huylu seyri, sakinleştirme teknikleri ve alarm bulguları anlatılmalıdır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.”, “Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.” ve “Ağlama atakları özellikle akşamları tekrarlayan özellik göstermektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Aileyi bilgilendirme, rahatlatma ve güvenli destekleyici bakım önerileri en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebek yaşına uygun kilo almaktadır.

Kanıt 2: Ateş, dehidratasyon, kanlı dışkı veya batın patolojisi yoktur.

Kanıt 3: Ağlama atakları özellikle akşamları tekrarlayan özellik göstermektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: İnfantil kolikte alarm bulgusu yoksa temel yaklaşım aile eğitimi ve destekleyici bakımdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 390: v196-new-390-kilo-alamama-ve-kronik-ishal

Başlık: Kilo alamama ve kronik ishal

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Tanısal paterni klinik ve objektif verilerle eşleştirme.

Learning Target: Çölyak hastalığını kronik ishal, büyüme geriliği ve anti-doku transglutaminaz IgA pozitifliğiyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, kronik ishal, karın şişliği ve kilo alamama nedeniyle getiriliyor. Ailesi, glüten içeren ek gıdalar başladıktan sonra dışkılamasının arttığını ve son bir yıldır boy-kilo artışının yavaşladığını belirtmektedir. Çocukta huzursuzluk, iştahsızlık ve ağız köşelerinde çatlama da fark edilmiştir. Ailede otoimmün tiroid hastalığı öyküsü vardır.

Demografi: 5 yaşında kız çocuk | Setting: Klinik değerlendirme

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Çocuk zayıf ve hafif soluk görünümündedir.
- Batın hafif distandüddür.
- Ağız köşelerinde fissürler vardır.
- Ödem yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündürülen belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Anti-doku transglutaminaz IgA

Etiket: Anti-doku transglutaminaz IgA | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Çölyak hastalığını destekler. | Sonuç yorumu: Çölyak hastalığını destekler. | Sonuç başlığı: Anti-doku transglutaminaz IgA | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Çölyak hastalığını destekler. | Satırlar: Anti-doku transglutaminaz IgA / Pozitif saptandı. // Çölyak hastalığını destekler.

Tetkik 2: Total IgA

Etiket: Total IgA | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: IgA temelli serolojinin yorumlanabilir olduğunu gösterir. | Sonuç yorumu: IgA temelli serolojinin yorumlanabilir olduğunu gösterir. | Sonuç başlığı: Total IgA | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: IgA temelli serolojinin yorumlanabilir olduğunu gösterir. | Satırlar: Total IgA / Normal saptandı. // IgA temelli serolojinin yorumlanabilir olduğunu gösterir.

Tetkik 3: Hemogloblin

Etiket: Hemogloblin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Malabsorpsiyona bağlı anemi gelişebileceğini destekler. | Sonuç yorumu: Malabsorpsiyona bağlı anemi gelişebileceğini destekler. | Sonuç başlığı: Hemogloblin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Malabsorpsiyona bağlı anemi gelişebileceğini destekler. | Satırlar: Hemogloblin / 10.0 g/dL // Malabsorpsiyona bağlı anemi gelişebileceğini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çölyak hastalığı
B) Laktoz intoleransı
C) Akut viral gastroenterit
D) İnfantil kolik
E) Fonksiyonel kabızlık

Doğru Cevap: Çölyak hastalığı

- A) Çölyak hastalığı: Çölyak hastalığı kronik ishal, büyüme geriliği ve pozitif anti-doku transglutaminaz IgA ile en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Kronik ishal ve karın şişliği vardır.” ve “Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
B) Laktoz intoleransı: Laktoz intoleransı süt ürünleriyle ilişkili osmotik semptomlar yapar; otoimmün seroloji pozitifliği beklenmez. Bu olguda “Kronik ishal ve karın şişliği vardır.” ve “Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Çölyak hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
C) Akut viral gastroenterit: Vakadaki Kronik ishal ve karın şişliği vardır ve Boy-kilo artışı yavaşlamıştır. Bu olguda “Kronik ishal ve karın şişliği vardır.” ve “Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Çölyak hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
D) İnfantil kolik: Vakadaki Kronik ishal ve karın şişliği vardır ve Boy-kilo artışı yavaşlamıştır. Bu olguda “Kronik ishal ve karın şişliği vardır.” ve “Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Çölyak hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.
E) Fonksiyonel kabızlık: Vakadaki Kronik ishal ve karın şişliği vardır ve Boy-kilo artışı yavaşlamıştır. Bu olguda “Kronik ishal ve karın şişliği vardır.” ve “Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.” ipuçları tanısal karar açısından Çölyak hastalığı seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kilo alamama ve kronik ishal olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. “Kronik ishal ve karın şişliği vardır.” ve “Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.” birlikte okunduğunda Çölyak hastalığı seçeneği öne çıkar; “Anti-doku transglutaminaz IgA pozitif ve total IgA normaldir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik ishal, karın distansiyonu, büyüme geriliği, anemi ve anti-doku transglutaminaz IgA pozitifliği çölyak hastalığını düşündürür. Total IgA normal olduğundan IgA temelli test güvenilir şekilde yorumlanabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kronik ishal ve karın şişliği vardır.”, “Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.” ve “Anti-doku transglutaminaz IgA pozitif ve total IgA normaldir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Çölyak hastalığı en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Kronik ishal ve karın şişliği vardır.

Kanıt 2: Boy-kilo artışı yavaşlamıştır.

Kanıt 3: Anti-doku transglutaminaz IgA pozitif ve total IgA normaldir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Çölyak taramasında total IgA düzeyi serolojinin doğru yorumlanması için önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 391: v337-peds-clinical-unique-001-infantta-hisilti-ve-beslenememe

Başlık: İnfantta hisilti ve beslenememe

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Çocuk hastada tedavi seçimini klinik bağlam ve güvenlik açısından değerlendirme.

Learning Target: Hipoksik bronşiolitte destek tedavisini seçebilme ve rutin bronkodilatör-antibiyotik kullanımından kaçınabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, burun akıntısı sonrası gelişen öksürük, hisilti ve beslenememe nedeniyle getiriliyor. Ailesi üç gündür burun akıntısı ve hafif ateş olduğunu, son 24 saatte hızlı nefes alma ve emme süresinde belirgin azalma geliştiğini belirtmektedir. Evde astım ilacı kullanmamıştır. Daha önce benzer hisilti atağı yoktur ve prematürite öyküsü bulunmamaktadır.

Demografi: 4 aylık erkek bebek | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 82/48 mmHg | Nabız: 128/dk | Solunum: 62/dk | SpO₂: %89% | Ateş: 37.8°C | Şok indeksi: 1,56 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek takipneiktir ve subkostal çekilmeleri vardır.
- Yaygın ince raller ve hisilti duyulur.
- Burun kanadı solunumu belirgindir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Nazofarengeal viral panel

Etiket: Nazofarengeal viral panel | Tip: microbiology | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: RSV pozitif saptandı. | Klinik anlam: Bronşiolit etkenini destekler. | Sonuç yorumu: Bronşiolit etkenini destekler. | Sonuç başlığı: Nazofarengeal viral panel | Sonuç özeti: RSV pozitif saptandı. | Yorum: Bronşiolit etkenini destekler. | Satırlar: Nazofarengeal viral panel / RSV pozitif saptandı. // Bronşiolit etkenini destekler.

Tetkik 2: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Fokal lobar konsolidasyon izlenmedi; hiperinflasyon bulguları mevcuttur. | Klinik anlam: Bakteriyel pnömoni lehine belirgin odak yoktur. | Sonuç yorumu: Bakteriyel pnömoni lehine belirgin odak yoktur. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Fokal lobar konsolidasyon izlenmedi; hiperinflasyon bulguları mevcuttur. | Yorum: Bakteriyel pnömoni lehine belirgin odak yoktur. | Satırlar: Akciğer grafisi / Fokal lobar konsolidasyon izlenmedi; hiperinflasyon bulguları mevcuttur. // Bakteriyel pnömoni lehine belirgin odak yoktur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte en uygun başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnhal kortikosteroidi kontrol tedavisi olarak başlamak
- B) Rutin geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik başlamak
- C) Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması
- D) Sistemik kortikosteroidi rutin başlangıç tedavisi olarak kullanmak
- E) Antitussif semptomatik tedaviyle ayakta izlem planlamak

Doğru Cevap: Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması

- A) İnhal kortikosteroidi kontrol tedavisi olarak başlamak: Vakadaki Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır ve Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur. Bu olguda "Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Rutin geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik başlamak: Rutin antibiyotik viral bronşiolitte gerekli değildir; bakteriyel odak veya sepsis bulgusu olmadıkça gereksizdir. Bu olguda "Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması: Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyon bronşiolitte hipoksemi ve beslenme yetersizliğini hedefleyen doğru başlangıç tedavisidir. Vakadaki "Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur." ipuçları klinik olarak gerekçelenir.
- D) Sistemik kortikosteroidi rutin başlangıç tedavisi olarak kullanmak: Vakadaki Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır ve Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur. Bu olguda "Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Antitussif semptomatik tedaviyle ayakta izlem planlamak: Vakadaki Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır ve Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur. Bu olguda "Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur." ipuçları tedavi önceliği açısından Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: İnfantta hisilti ve beslenememe olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. "Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır." ve "Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur." birlikte okunduğunda Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması seçeneği öne çıkar; "Akciğer grafisinde fokal bakteriyel konsolidasyon izlenmemiştir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: RSV bronşioliti küçük infantlarda alt hava yolu ödemi, sekresyon ve hava hapsiyle solunum sıkıntısı yapar. Tedavinin temel oksijenasyon, nazal sekresyon temizliği ve hidrasyon desteğidir; rutin antibiyotik, steroid veya bronkodilatör her olguda gerekli değildir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır.", "Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur." ve "Akciğer grafisinde fokal bakteriyel konsolidasyon izlenmemiştir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Oksijen desteği, nazal aspirasyon ve hidrasyonun sağlanması en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Bebekte RSV pozitifliğiyle birlikte ilk hisiltılı alt solunum yolu atağı vardır.

Kanıt 2: Oksijen satürasyonu oda havasında %89'dur ve çekimler mevcuttur.

Kanıt 3: Akciğer grafisinde fokal bakteriyel konsolidasyon izlenmemiştir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Bronşiolit tedavisinin temel destek tedavisidir; hipoksemi varsa oksijen verilmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 392: v337-peds-clinical-unique-002-merdiven-cikmada-zorlanma

Başlık: Merdiven çıkmada zorlanma

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Çocuk hastada tanıyı klinik ve objektif bulgularla ayırt etme.

Learning Target: Duchenne Musküler Distrofisinde Proksimal Kas Güçsüzlüğü, Gowers bulgusu ve distrofin ilişkisini tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, sık düşme, koşamama ve merdiven çıkmada zorlanma nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun yaşitlarına göre geç yürüdüğünü, son bir yıldır yerden kalkarken elleriyle bacaklarına tırmanır gibi destek aldığını ve baldırlarının belirgin kalın görüldüğünü belirtmektedir. Zihinsel gelişiminde hafif öğrenme güçlüğü dışında belirgin gerileme tariflenmemektedir.

Demografi: 5 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Çocukta proksimal kas güçsüzlüğü belirgindir.
- Yerden kalkarken Gowers manevrası izlenir.
- Baldırlarda psödohipertrofi vardır.
- Derin tendon refleksleri hafif azalmıştır; duyu muayenesi normaldir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kreatin kinaz

Etiket: Kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kas membran hasarını destekler. | Sonuç yorumu: Kas membran hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Kreatin kinaz | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: Kas membran hasarını destekler. | Satırlar: Kreatin kinaz / 14500 U/L // Kas membran hasarını destekler.

Tetkik 2: Genetik analiz

Etiket: Genetik analiz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: DMD geninde patojenik varyant saptandı. | Klinik anlam: Distrofin ilişkili Musküler Distrofi lehinedir. | Sonuç yorumu: Distrofin ilişkili Musküler Distrofi lehinedir. | Sonuç başlığı: Genetik analiz | Sonuç özeti: DMD geninde patojenik varyant saptandı. | Yorum: Distrofin ilişkili Musküler Distrofi lehinedir. | Satırlar: Genetik analiz / DMD geninde patojenik varyant saptandı. // Distrofin ilişkili Musküler Distrofi lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Spinal Musküler atrofi tip 1
B) Myastenia gravis
C) Serebral palsi spastik dipleji
D) Guillain-Barré sendromu
E) Duchenne Musküler distrofisi

Doğru Cevap: Duchenne Musküler distrofisi

A) Spinal Musküler atrofi tip 1: Spinal Musküler atrofi tip 1 daha erken bebeklikte ağır hipotoni ve solunum-beslenme güçlüğüyle seyreder; baldır psödohipertrofisi tipik değildir. Bu olguda "Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir." ve "Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır." ipuçları tanısız karar açısından Duchenne Musküler distrofisi seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Myastenia gravis: Myastenia gravis güçlükle dalgalandır ve oküler-bulber bulgular belirgin olabilir; CK bu kadar yüksek beklenmez. Bu olguda "Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir." ve "Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır." ipuçları tanısız karar açısından Duchenne Musküler distrofisi seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Serebral palsi spastik dipleji: Serebral palsi spastik diplejide üst motor nöron bulguları ve spastisite beklenir; progresif CK yüksekliği tipik değildir. Bu olguda "Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir." ve "Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır." ipuçları tanısız karar açısından Duchenne Musküler distrofisi seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Guillain-Barré sendromu: Guillain-Barré sendromu akut/subakut çıkan güçsüzlük ve arefleksiyle seyreder; yıllar içinde progresif baldır psödohipertrofisi yapmaz. Bu olguda "Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir." ve "Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır." ipuçları tanısız karar açısından Duchenne Musküler distrofisi seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Duchenne Musküler distrofisi: Duchenne Musküler distrofisi erkek çocukta Gowers bulgusu, baldır psödohipertrofisi ve çok yüksek kreatin kinazla en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir." ve "Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Merdiven çıkmada zorlanma olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. "Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir." ve "Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır." birlikte okunduğunda Duchenne Musküler distrofisi seçeneği öne çıkar; "Kreatin kinaz belirgin yüksek ve DMD geninde patojenik varyant vardır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erkek çocukta erken çocuklukta başlayan progresif proksimal güçsüzlük, Gowers manevrası, baldır psödohipertrofisi, çok yüksek kreatin kinaz ve DMD gen varyantı Duchenne Musküler distrofisini düşündürür. Distrofin eksikliği kas liflerinde membran stabilitesini bozar. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir.", "Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır." ve "Kreatin kinaz belirgin yüksek ve DMD geninde patojenik varyant vardır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Duchenne Musküler distrofisi en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk erkek ve erken yaşta progresif motor güçsüzlük göstermektedir.

Kanıt 2: Gowers manevrası ve baldır psödohipertrofisi saptanmıştır.

Kanıt 3: Kreatin kinaz belirgin yüksek ve DMD geninde patojenik varyant vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayırır.

Exam Pearl: Duchenne Musküler distrofisinde distrofin yokluğu kas membranını kırılganlaştırır ve CK çok yükselir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 393: v337-peds-clinical-unique-003-ates-sirasinda-kisa-nobet

Başlık: Ateş sırasında kısa nöbet

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Çocuk hastada tanıyı klinik ve objektif bulgularla ayırt etme.

Learning Target: Basit febril nöbeti ayırt edip aile bilgilendirmesi ve ateş odağı değerlendirmesini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, ateş sırasında kısa süren jeneralize kasılma sonrası getiriliyor. Ailesi çocuğun üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olduğunu, evde ateşi yükselirken tüm vücudunda kasılma ve gözlerde kayma geliştiğini belirtmektedir. Nöbet yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır. Gün içinde ikinci nöbet olmamış, daha önce afebril nöbet öyküsü bulunmamaktadır.

Demografi: 20 aylık kız çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.9°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk acilde uyanık ve yaşına uygun etkileşim kurmaktadır.
- Ense sertliği yoktur.
- Fokal nörolojik defisit saptanmaz.
- Kulak muayenesinde hafif viral üst solunum yolu bulguları vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Hipoglisemi dışlanmıştır. | Sonuç yorumu: Hipoglisemi dışlanmıştır. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Hipoglisemi dışlanmıştır. | Satırlar: Kan glukozu / 92 mg/dL / 70-100 mg/dL / Hipoglisemi dışlanmıştır.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu tablo için en uygun yorum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hipoglisemik nöbet
B) Basit febril nöbet
C) Fokal epilepsi nöbeti
D) Uzamış afebril epileptik nöbet
E) Menenjit kesin tanısı

Doğru Cevap: Basit febril nöbet

A) Hipoglisemik nöbet: Vakadaki Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir ve Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır. Bu olguda “Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.” ve “Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Basit febril nöbet seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Basit febril nöbet: Basit febril nöbet yaş aralığı, kısa jeneralize nöbet süresi ve nörolojik normale dönüş ile en uyumlu tanımlamadır. Vakadaki “Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.” ve “Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Fokal epilepsi nöbeti: Fokal epilepsi nöbetinde lokal başlangıç veya fokal nörolojik bulgular beklenir; bu nöbet jeneralizedir. Bu olguda “Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.” ve “Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Basit febril nöbet seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Uzamış afebril epileptik nöbet: Uzamış afebril epileptik nöbet ateşle ilişkili kısa ve kendiliğinden sonlanan bu tabloyu açıklamaz; nöbet süresi ve bağlam basit febril nöbet lehinedir. Bu olguda “Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.” ve “Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Basit febril nöbet seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Menenjit kesin tanısı: Menenjit tanısı ense sertliği, bilinç bozukluğu veya meningeal bulgularla desteklenmelidir; bu olguda kesin menenjit bulgusu yoktur. Bu olguda “Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.” ve “Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Basit febril nöbet seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Ateş sırasında kısa nöbet olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.” ve “Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.” birlikte okunduğunda Basit febril nöbet seçeneği öne çıkar; “Acil değerlendirmede ense sertliği ve fokal nörolojik defisit saptanmamıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Altı ay-beş yaş aralığında, ateşle ilişkili, 15 dakikadan kısa süren, jeneralize ve 24 saat içinde tekrarlamayan nöbet basit febril nöbetle uyumludur. Çocuk nörolojik olarak normale dönmüşse yaklaşım ateş odağını değerlendirmek ve aileyi bilgilendirmektir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.”, “Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.” ve “Acil değerlendirmede ense sertliği ve fokal nörolojik defisit saptanmamıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Basit febril nöbet en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk 20 aylıktır ve nöbet ateş yükselirken gelişmiştir.

Kanıt 2: Nöbet jeneralize, yaklaşık 2 dakika sürmüş ve kendiliğinden sonlanmıştır.

Kanıt 3: Acil değerlendirmede ense sertliği ve fokal nörolojik defisit saptanmamıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Basit febril nöbet jeneralize, kısa süreli ve 24 saat içinde tekrarlamayan ateş ilişkili nöbettir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 394:

v337-peds-clinical-unique-004-tekrarlayan-atesli-idrar-yolu-enfeksiyonu

Başlık: Tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Çocuk hastada en uygun tanısal testi seçme.

Learning Target: Vezikoüreteral reflüye bağlı tekrarlayan febril İYE’de görüntüleme ve renal skar riskini yorumlayabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, son bir yılda üçüncü kez ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle değerlendiriliyor. Ailesi önceki ataklarda yüksek ateş, kusma ve yan ağrısı olduğunu, antibiyotikle düzeldiğini belirtmektedir. Bu atakta da 39°C ateş, iştahsızlık ve kötü kokulu idrar gelişmiştir. Tuvalet eğitimine yeni başlamıştır; kabızlık yakınması da vardır.

Demografi: 3 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.9°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk hafif halsizdir.
- Suprapubik hassasiyet ve sağ kostovertebral açı hassasiyeti vardır.
- Genital muayenede lokal irritasyon dışında belirgin anomali saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: İdrar kültürü

Etiket: İdrar kültürü | Tip: microbiology | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: Escherichia coli üremesi saptandı. | Klinik anlam: Febril idrar yolu enfeksiyonunu destekler. | Sonuç yorumu: Febril idrar yolu enfeksiyonunu destekler. | Sonuç başlığı: İdrar kültürü | Sonuç özeti: Escherichia coli üremesi saptandı. | Yorum: Febril idrar yolu enfeksiyonunu destekler. | Satırlar: İdrar kültürü / Escherichia coli üremesi saptandı. // Febril idrar yolu enfeksiyonunu destekler.

Tetkik 2: Renal ultrasonografi

Etiket: Renal ultrasonografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ böbrekte hafif pelvikaliektazi izlendi. | Klinik anlam: Üst üriner sistem etkilenimi açısından ileri değerlendirme gerektirir. | Sonuç yorumu: Üst üriner sistem etkilenimi açısından ileri değerlendirme gerektirir. | Sonuç başlığı: Renal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sağ böbrekte hafif pelvikaliektazi izlendi. | Yorum: Üst üriner sistem etkilenimi açısından ileri değerlendirme gerektirir. | Satırlar: Renal ultrasonografi / Sağ böbrekte hafif pelvikaliektazi izlendi. // Üst üriner sistem etkilenimi açısından ileri değerlendirme gerektirir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Tekrarlayan febril idrar yolu enfeksiyonu ve ultrason bulgusu olan bu çocukta reflü değerlendirmesi için en uygun test aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üst gastrointestinal pasaj grafisi
B) Elektroensefalografi
C) Akciğer tomografisi
D) Voiding sistoüretrografi
E) Alerji deri testi

Doğru Cevap: Voiding sistoüretrografi

- A) Üst gastrointestinal pasaj grafisi: Üst gastrointestinal pasaj grafisi özofagus-mide-duodenum değerlendirmesine yöneliktir; üriner reflüyü göstermez. Bu olguda “Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.” ve “İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal test seçimi açısından Voiding sistoüretrografi seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Elektroensefalografi: Vakadaki Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir ve İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır. Bu olguda “Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.” ve “İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal test seçimi açısından Voiding sistoüretrografi seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Akciğer tomografisi: Vakadaki Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir ve İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır. Bu olguda “Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.” ve “İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal test seçimi açısından Voiding sistoüretrografi seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Voiding sistoüretrografi: Voiding sistoüretrografi mesane dolum ve işeme sırasında reflüyü gösterdiği için bu olguda uygun testtir. Vakadaki “Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.”, “İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.” ve “Renal ultrasonografide pelvikaliektazi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Voiding sistoüretrografi en tutarlı yanıtıdır.
- E) Alerji deri testi: Vakadaki Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir ve İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır. Bu olguda “Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.” ve “İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.” ipuçları tanısal test seçimi açısından Voiding sistoüretrografi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu olgusunda klinik karar tanısal test seçimi üzerine kuruludur. “Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.” ve “İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Voiding sistoüretrografi seçeneği öne çıkar; “Renal ultrasonografide pelvikaliektazi izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Tekrarlayan febril idrar yolu enfeksiyonu ve ultrasonografide pelvikaliektazi vezikoüreteral reflü açısından değerlendirme gerektirir. Voiding sistoüretrografi reflünün mesaneden üretere ve böbreğe geri kaçışını göstermek için kullanılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.”, “İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.” ve “Renal ultrasonografide pelvikaliektazi izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Voiding sistoüretrografi en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Çocuk son bir yılda tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçirmiştir.

Kanıt 2: İdrar kültüründe Escherichia coli üremesi saptanmıştır.

Kanıt 3: Renal ultrasonografide pelvikaliektazi izlenmiştir.

Core Knowledge: Tetkik seçimi sorularında amaç en pahalı veya en ileri testi değil, mevcut klinik aşamada tanıyı doğrulayan veya yönetimi değiştiren testi seçmektir. Testin zamanlaması, duyarlılık/özellik dengesi ve acil güvenlik etkisi birlikte değerlendirilmelidir.

Exam Pearl: Tekrarlayan febril İYE’de vezikoüreteral reflü renal skar riski açısından değerlendirilmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 395: v337-peds-clinical-unique-005-kucuk-cocukta-tek-diz-sisligi

Başlık: Küçük çocukta tek diz şişliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Çocuk hastada en uygun tanısal testi seçme.

Learning Target: Oligoartiküler juvenil idiyopatik artritte asemptomatik anterior üveit taraması gerekliliğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, üç aydır devam eden sağ diz şişliği, sabah tutukluğu ve topallama nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun özellikle sabahları sağ dizini tam açmakta zorlandığını, gün içinde hareket ettikçe topallamasının azaldığını belirtmektedir. Ateş, döküntü, kilo kaybı veya yakın zamanda travma öyküsü yoktur. Ağrı çok şiddetli değildir; ancak diz şişliği kalıcıdır ve aralıklı olarak artmaktadır.

Demografi: 4 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Sağ dizde efüzyon, hafif sıcaklık artışı ve hareket açıklığında kısıtlılık vardır.
- Diğer eklemlerde belirgin artrit saptanmaz.
- Çocuk genel olarak iyi görünmektedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Antinükleer antikor

Etiket: Antinükleer antikor | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Pozitif saptandı. | Klinik anlam: Oligoartiküler JIA'da kronik anterior üveit riskini artırır. | Sonuç yorumu: Oligoartiküler JIA'da kronik anterior üveit riskini artırır. | Sonuç başlığı: Antinükleer antikor | Sonuç özeti: Pozitif saptandı. | Yorum: Oligoartiküler JIA'da kronik anterior üveit riskini artırır. | Satırlar: Antinükleer antikor / Pozitif saptandı. // Oligoartiküler JIA'da kronik anterior üveit riskini artırır.

Tetkik 2: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Hafif yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kronik inflamasyonu destekler. | Sonuç yorumu: Kronik inflamasyonu destekler. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Hafif yüksek saptandı. | Yorum: Kronik inflamasyonu destekler. | Satırlar: C-reaktif protein / 16 mg/L / <5 mg/L / Kronik inflamasyonu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta asemptomatik komplikasyon taraması için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yarık lamba ile göz muayenesi
B) Kolonoskopi
C) İştme testi
D) Kraniyal bilgisayarlı tomografi
E) Rutin karaciğer biyopsisi

Doğru Cevap: Yarık lamba ile göz muayenesi

A) Yarık lamba ile göz muayenesi: Yarık lamba muayenesi oligoartiküler JIA'da asemptomatik anterior üveiti saptamak için doğru tarama yöntemidir. Vakadaki "Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır." ve "Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir. B) Kolonoskopi: Kolonoskopi inflamatuvar bağırsak hastalığı şüphesinde kullanılabilir; bu olguda öncelikli risk sessiz üveittir. Bu olguda "Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır." ve "Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır." ipuçları klinik karar açısından Yarık lamba ile göz muayenesi seçeneğini daha güçlü kılar. C) İştme testi: İştme testi bazı sendromik durumlarda gerekli olabilir; ANA pozitif oligoartiküler JIA'da temel tarama göz muayenesidir. Bu olguda "Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır." ve "Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır." ipuçları klinik karar açısından Yarık lamba ile göz muayenesi seçeneğini daha güçlü kılar. D) Kraniyal bilgisayarlı tomografi: Kraniyal tomografi nörolojik acil bulgu olmadıkça bu eklem hastalığının göz komplikasyonunu değerlendirmez. Bu olguda "Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır." ve "Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır." ipuçları klinik karar açısından Yarık lamba ile göz muayenesi seçeneğini daha güçlü kılar. E) Rutin karaciğer biyopsisi: Karaciğer biyopsisi kronik artrit ve üveit riskini değerlendirmek için uygun bir tarama değildir. Bu olguda "Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır." ve "Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır." ipuçları klinik karar açısından Yarık lamba ile göz muayenesi seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Küçük çocukta tek diz şişliği olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. "Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır." ve "Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır." birlikte okunduğunda Yarık lamba ile göz muayenesi seçeneği öne çıkar; "Antinükleer antikor pozitifliği kronik anterior üveit riskini artırmaktadır." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Küçük kız çocukta altı haftadan uzun süren az sayıda eklem tutulumu, sabah tutukluğu ve ANA pozitifliği oligoartiküler juvenil idiyopatik artriti düşündürür. Bu grupta kronik anterior üveit asemptomatik seyredebilir; bu nedenle düzenli yarık lamba muayenesi gereklidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır.", "Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır." ve "Antinükleer antikor pozitifliği kronik anterior üveit riskini artırmaktadır." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Yarık lamba ile göz muayenesi en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Artrit üç aydır sürmektedir ve tutulum tek dizle sınırlıdır.

Kanıt 2: Sabah tutukluğu gün içinde hareketle azalmaktadır.

Kanıt 3: Antinükleer antikor pozitifliği kronik anterior üveit riskini artırmaktadır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Oligoartiküler JIA'da üveit sessiz olabilir; göz taraması semptom beklenmeden yapılmalıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 396: v337-peds-clinical-unique-006-karinda-kitle-ve-kilo-kaybi

Başlık: Karında kitle ve kilo kaybı

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Çocuk hastada tanıyı klinik ve objektif bulgularla ayırt etme.

Learning Target: Nöroblastomda abdominal kitle, sistemik bulgular ve katekolamin metabolit yüksekliğiyle tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, karında fark edilen sert kitle, kilo kaybı ve aralıklı ateş nedeniyle getiriliyor. Ailesi son iki ayda çocuğun iştahının azaldığını, kilo alamadığını ve geceleri terlediğini belirtmektedir. Son haftalarda karın sol üst tarafında sertlik fark edilmiştir. Kabızlık ve huzursuzluk atakları vardır; idrar renginde belirgin değişiklik tariflenmemektedir.

Demografi: 2 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 118/76 mmHg | Nabız: 126/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,07 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk zayıf ve huzursuz görünmektedir.
- Batında orta hattı geçen, düzensiz ve sert kitle palpe edilir.
- Hafif periorbital morluk benzeri renk değişikliği vardır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Abdominal ultrasonografi

Etiket: Abdominal ultrasonografi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sol adrenal lojdan kaynaklandığı düşünülen heterojen solid kitle izlendi. | Klinik anlam: Adrenal kaynaklı tümör olasılığını destekler. | Sonuç yorumu: Adrenal kaynaklı tümör olasılığını destekler. | Sonuç başlığı: Abdominal ultrasonografi | Sonuç özeti: Sol adrenal lojdan kaynaklandığı düşünülen heterojen solid kitle izlendi. | Yorum: Adrenal kaynaklı tümör olasılığını destekler. | Satırlar: Abdominal ultrasonografi / Sol adrenal lojdan kaynaklandığı düşünülen heterojen solid kitle izlendi. // Adrenal kaynaklı tümör olasılığını destekler.

Tetkik 2: İdrar katekolamin metabolitleri

Etiket: İdrar katekolamin metabolitleri | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: VMA ve HVA düzeyleri yüksek saptandı. | Klinik anlam: Nöroblastom lehine biyokimyasal bulgudur. | Sonuç yorumu: Nöroblastom lehine biyokimyasal bulgudur. | Sonuç başlığı: İdrar katekolamin metabolitleri | Sonuç özeti: VMA ve HVA düzeyleri yüksek saptandı. | Yorum: Nöroblastom lehine biyokimyasal bulgudur. | Satırlar: İdrar katekolamin metabolitleri / VMA ve HVA düzeyleri yüksek saptandı. // Nöroblastom lehine biyokimyasal bulgudur.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hepatoblastom
B) Lenfanjiyom
C) Nöroblastom
D) Basit fekal impaksiyon
E) Wilms tümörü

Doğru Cevap: Nöroblastom

- A) Hepatoblastom: Hepatoblastom karaciğer kaynaklı kitle ve alfa-fetoprotein yüksekliğiyle ilişkilidir; adrenal kitle paternini açıklamaz. Bu olguda “Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.” ve “Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Nöroblastom seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Lenfanjiyom: Lenfanjiyom kistik lenfatik malformasyondur; katekolamin metabolit yüksekliği ve adrenal solid kitle yapmaz. Bu olguda “Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.” ve “Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Nöroblastom seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Nöroblastom: Nöroblastom adrenal kaynaklı kitle, sistemik bulgular ve katekolamin metabolit yüksekliğiyle uyumlu tanıdır. Vakadaki “Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.” ve “Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- D) Basit fekal impaksiyon: Fekal impaksiyon kabızlıkla kitle hissi verebilir ancak heterojen adrenal kitle ve VMA/HVA yüksekliğini açıklamaz. Bu olguda “Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.” ve “Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Nöroblastom seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Wilms tümörü: Wilms tümörü genellikle böbrek kaynaklı, daha düzgün sınırlı ve orta hattı geçmeyen kitleyle düşünülür; VMA/HVA yüksekliği beklenmez. Bu olguda “Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.” ve “Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Nöroblastom seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Karında kitle ve kilo kaybı olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.” ve “Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.” birlikte okunduğunda Nöroblastom seçeneği öne çıkar; “İdrarda VMA ve HVA düzeyleri yüksek saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Küçük çocukta adrenal kaynaklı, düzensiz, orta hattı geçebilen abdominal kitle; sistemik bulgular ve idrarda VMA/HVA yüksekliği nöroblastomu düşündürür. Nöroblastom nöral krest kökenli sempatik sinir sistemi tümörüdür ve katekolamin metabolitleri artabilir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.”, “Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.” ve “İdrarda VMA ve HVA düzeyleri yüksek saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Nöroblastom en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Kitle adrenal lojdan kaynaklanan heterojen solid yapı olarak tanımlanmıştır.

Kanıt 2: Kitle orta hattı geçmektedir ve sistemik kilo kaybı-terleme bulguları vardır.

Kanıt 3: İdrarda VMA ve HVA düzeyleri yüksek saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Nöroblastomda idrar VMA/HVA yüksekliği ve orta hattı geçebilen adrenal kitle önemli ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 397:

v337-peds-clinical-unique-007-ust-solunum-yolu-enfeksiyonu-sonrasi-topal

Başlık: Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası topallama

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Çocuk hastada tanıyı klinik ve objektif bulgularla ayırt etme.

Learning Target: Geçici sinoviti kalça ağrısı, iyi genel durum ve düşük inflamatuvar belirteçlerle septik artritten ayırt edebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, birkaç gündür süren sağ kalça ağrısı ve topallama nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun bir hafta önce burun akıntısı ve hafif boğaz ağrısı geçirdiğini, sonrasında sağ bacağına hafifçe aksatarak yürümeye başladığını belirtmektedir. Ateş olmamıştır; çocuk oyun oynamaya devam edebilmekte ancak uzun yürüyüşte kalçasını tutmaktadır. Travma öyküsü yoktur.

Demografi: 5 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 92/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.9°C | Şok indeksi: 1,05 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk genel durumu iyi ve afebrildir.
- Sağ kalça iç rotasyonunda hafif ağrı vardır ancak pasif hareketler çok şiddetli ağrılı değildir.
- Diz ve ayak bileği muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: C-reaktif protein

Etiket: C-reaktif protein | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal sınıra yakın saptandı. | Klinik anlam: Bakteriyel septik artrit lehine güçlü inflamasyon yoktur. | Sonuç yorumu: Bakteriyel septik artrit lehine güçlü inflamasyon yoktur. | Sonuç başlığı: C-reaktif protein | Sonuç özeti: Normal sınıra yakın saptandı. | Yorum: Bakteriyel septik artrit lehine güçlü inflamasyon yoktur. | Satırlar: C-reaktif protein / 4 mg/L / <5 mg/L / Bakteriyel septik artrit lehine güçlü inflamasyon yoktur.

Tetkik 2: Kalça ultrasonografisi

Etiket: Kalça ultrasonografisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ kalçada az miktarda eklem sıvısı izlendi. | Klinik anlam: Reaktif efüzyonu destekleyebilir. | Sonuç yorumu: Reaktif efüzyonu destekleyebilir. | Sonuç başlığı: Kalça ultrasonografisi | Sonuç özeti: Sağ kalçada az miktarda eklem sıvısı izlendi. | Yorum: Reaktif efüzyonu destekleyebilir. | Satırlar: Kalça ultrasonografisi / Sağ kalçada az miktarda eklem sıvısı izlendi. / / Reaktif efüzyonu destekleyebilir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Legg-Calvé-Perthes hastalığı
B) Femur shaft kırığı
C) Osteosarkom
D) Septik kalça artriti
E) Geçici kalça sinoviti

Doğru Cevap: Geçici kalça sinoviti

A) Legg-Calvé-Perthes hastalığı: Legg-Calvé-Perthes hastalığı daha kronik seyirli femur başı avasküler nekrozudur; viral sonrası kısa süreli efüzyon paternini açıklamaz. Bu olguda “Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Geçici kalça sinoviti seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Femur shaft kırığı: Femur shaft kırığı belirgin travma, deformite ve yük verememe ile beklenir; travma öyküsü yoktur. Bu olguda “Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Geçici kalça sinoviti seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Osteosarkom: Osteosarkom ilerleyici kemik ağrısı ve radyolojik agresif kemik lezyonu ile düşünülür; bu olgu reaktif kalça efüzyonuna uymaktadır. Bu olguda “Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Geçici kalça sinoviti seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Septik kalça artriti: Septik kalça artritinde yüksek ateş, toksik görünüm, ciddi pasif hareket ağrısı ve belirgin inflamasyon beklenir; bu olguda bunlar yoktur. Bu olguda “Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Geçici kalça sinoviti seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Geçici kalça sinoviti: Geçici kalça sinoviti viral enfeksiyon sonrası iyi görünümülü afebril çocukta hafif kalça ağrısı ve düşük inflamasyonla en uyumludur. Vakadaki “Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası topallama olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.” birlikte okunduğunda Geçici kalça sinoviti seçeneği öne çıkar; “CRP normal sınıra yakındır ve kalçada az miktarda sıvı vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası iyi genel durumlu, afebril çocukta hafif kalça ağrısı, sınırlı efüzyon ve düşük inflamatuvar belirteç geçici sinoviti düşündürür. Septik artritte genellikle toksik görünüm, yüksek ateş, belirgin hareket kısıtlılığı ve yüksek inflamatuvar belirteçler beklenir. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.”, “Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.” ve “CRP normal sınıra yakındır ve kalçada az miktarda sıvı vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Geçici kalça sinoviti en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yakınmalar üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Çocuk afebril ve genel durumu iyi görünmektedir.

Kanıt 3: CRP normal sınıra yakındır ve kalçada az miktarda sıvı vardır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtın ayrılır.

Exam Pearl: Topallayan çocukta ateş, toksik görünüm ve yüksek CRP septik artrit açısından uyarıcıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 398: v337-peds-clinical-unique-008-duzenli-tekrarlayan-ates-ataklari

Başlık: Düzenli tekrarlayan ateş atakları

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Çocuk hastada tanıyı klinik ve objektif bulgularla ayırt etme.

Learning Target: PFAPA sendromunu düzenli ateş atakları, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenitle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, yaklaşık ayda bir tekrarlayan yüksek ateş, ağız içi aftlar ve boğaz ağrısı nedeniyle getiriliyor. Ailesi atakların neredeyse 4 haftada bir başladığını, 3-4 gün sürdüğünü ve aralarda çocuğun tamamen sağlıklı olduğunu belirtmektedir. Ataklarda boğaz ağrısı, ağız içinde küçük aftlar ve boyunda şişlik olmakta; antibiyotik kullanılsa da belirgin fark etmemektedir. Büyüme ve gelişmesi normaldir. Demografi: 4 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 100/64 mmHg | Nabız: 102/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 39.2°C | Şok indeksi: 1,02 (yüksek)

Fizik Muayene

- Atak sırasında çocuk ateşli ancak toksik değildir.
- Tonsiller eritemlidir, ağız mukozasında aftöz ülserler vardır ve bilateral servikal lenf nodları hassastır.
- Karaciğer-dalak büyüklüğü yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Boğaz kültürü

Etiket: Boğaz kültürü | Tip: microbiology | Alt tip: Mikrobiyoloji | Özet: A grubu beta-hemolitik streptokok üremesi saptanmadı. | Klinik anlam: Tekrarlayan bakteriyel tonsilliti desteklemez. | Sonuç yorumu: Tekrarlayan bakteriyel tonsilliti desteklemez. | Sonuç başlığı: Boğaz kültürü | Sonuç özeti: A grubu beta-hemolitik streptokok üremesi saptanmadı. | Yorum: Tekrarlayan bakteriyel tonsilliti desteklemez. | Satırlar: Boğaz kültürü / A grubu beta-hemolitik streptokok üremesi saptanmadı. // Tekrarlayan bakteriyel tonsilliti desteklemez.

Tetkik 2: Atak arası tam kan sayımı

Etiket: Atak arası tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Siklik nötropeni gibi sürekli hematolojik bozukluk lehine değildir. | Sonuç yorumu: Siklik nötropeni gibi sürekli hematolojik bozukluk lehine değildir. | Sonuç başlığı: Atak arası tam kan sayımı | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Siklik nötropeni gibi sürekli hematolojik bozukluk lehine değildir. | Satırlar: Atak arası tam kan sayımı / Normal saptandı. // Siklik nötropeni gibi sürekli hematolojik bozukluk lehine değildir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ailevi Akdeniz ateşi
B) PFAPA sendromu
C) İmmün yetmezlik
D) Tekrarlayan streptokok tonsilliti
E) Siklik nötropeni

Doğru Cevap: PFAPA sendromu

- A) Ailevi Akdeniz ateşi: Ailevi Akdeniz ateşi daha çok serozit, karın ağrısı ve kısa ateş ataklarıyla ilişkilidir; aftöz stomatit-farenjit-adenit üçlüsü PFAPA lehinedir. Bu olguda "Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır." ve "Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından PFAPA sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) PFAPA sendromu: PFAPA sendromu periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit kombinasyonu en uyumlu tanıdır. Vakadaki "Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır." ve "Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir." ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- C) İmmün yetmezlik: İmmün yetmezlikte ağır, fırsatçı veya iyileşmeyen enfeksiyonlar ve büyüme geriliği beklenebilir; çocuk atak aralarında sağlıklıdır. Bu olguda "Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır." ve "Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından PFAPA sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Tekrarlayan streptokok tonsilliti: Tekrarlayan streptokok tonsillitinde kültür pozitifliği ve antibiyotik yanıtı beklenir; bu olguda kültür negatiftir. Bu olguda "Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır." ve "Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından PFAPA sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Siklik nötropeni: Siklik nötropenide atak sırasında nötropeni beklenir; atak arası normal kan sayımı ve klasik PFAPA bulguları daha ön plandadır. Bu olguda "Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır." ve "Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir." ipuçları tanısal karar açısından PFAPA sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Düzenli tekrarlayan ateş atakları olgusunda klinik karar tanısal karar üzerine kuruludur. "Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır." ve "Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir." birlikte okunduğunda PFAPA sendromu seçeneği öne çıkar; "Çocuk atak aralarında tamamen sağlıklıdır ve büyümesi normaldir." ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Düzenli periyodik ateş atakları, aftöz stomatit, farenjit, servikal adenit, atak aralarında tamamen sağlıklı olma ve normal büyüme PFAPA sendromunu düşündürür. Streptokok kültürünün negatif olması ve antibiyotik yanıtının belirgin olmaması bakteriyel tonsilliti geri plana iter. Bu olguda kararın temel ayrımı, "Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır.", "Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir." ve "Çocuk atak aralarında tamamen sağlıklıdır ve büyümesi normaldir." bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle PFAPA sendromu en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Ateş atakları yaklaşık 4 haftada bir düzenli tekrarlamaktadır.

Kanıt 2: Ataklara aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Çocuk atak aralarında tamamen sağlıklıdır ve büyümesi normaldir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: PFAPA'da ataklar periyodiktir ve çocuk atak aralarında sağlıklıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 399: v337-peds-clinical-unique-009-sarilik-ve-dalak-buyuklugu

Başlık: Sarılık ve dalak büyüklüğü

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Çocuk hastada tanıyı klinik ve objektif bulgularla ayırt etme.

Learning Target: Herediter sferositozu kronik hemoliz, splenomegali, yüksek MCHC ve sferositlerle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, aralıklı sarılık, halsizlik ve dalak büyüklüğü nedeniyle değerlendiriliyor. Ailesi çocuğun enfeksiyon dönemlerinde gözlerinde sararma ve halsizliğinin arttığını, bebekliğinden beri hafif anemisi olduğunu belirtmektedir. Babasında da çocuklukta safra taşı nedeniyle ameliyat öyküsü vardır. Kanama öyküsü veya kronik ishal yoktur.

Demografi: 9 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 96/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,09 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk hafif soluk ve subikteriktir.
- Dalak kot altında 3 cm palpe edilir.
- Karaciğer hafif ele gelir.
- Peteşi veya ekimoz yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Hemoglobin

Etiket: Hemoglobin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kronik hemolitik anemiyi destekler. | Sonuç yorumu: Kronik hemolitik anemiyi destekler. | Sonuç başlığı: Hemoglobin | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kronik hemolitik anemiyi destekler. | Satırlar: Hemoglobin / 9.6 g/dL // Kronik hemolitik anemiyi destekler.

Tetkik 2: MCHC

Etiket: MCHC | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Herediter sferositoz için destekleyici bulgudur. | Sonuç yorumu: Herediter sferositoz için destekleyici bulgudur. | Sonuç başlığı: MCHC | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Herediter sferositoz için destekleyici bulgudur. | Satırlar: MCHC / 37 g/dL / 32-36 g/dL / Herediter sferositoz için destekleyici bulgudur.

Tetkik 3: Periferik yayma

Etiket: Periferik yayma | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Santral solukluğu azalmış sferositler izlendi. | Klinik anlam: Sferositik hemolizi destekler. | Sonuç yorumu: Sferositik hemolizi destekler. | Sonuç başlığı: Periferik yayma | Sonuç özeti: Santral solukluğu azalmış sferositler izlendi. | Yorum: Sferositik hemolizi destekler. | Satırlar: Periferik yayma / Santral solukluğu azalmış sferositler izlendi. // Sferositik hemolizi destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Demir eksikliği anemisi
B) Aplastik anemi
C) Hemofili A
D) Herediter sferositoz
E) Beta talasemi taşıyıcılığı

Doğru Cevap: Herediter sferositoz

A) Demir eksikliği anemisi: Demir eksikliği anemisi genellikle mikrositoz ve düşük ferritinle seyreder; sferosit ve splenomegali tipik değildir. Bu olguda “Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.” ve “Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Herediter sferositoz seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Aplastik anemi: Aplastik anemide kemik iliği yetmezliği ve pansitopeni beklenir; hemolitik sarılık ve sferosit paternini açıklamaz. Bu olguda “Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.” ve “Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Herediter sferositoz seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Hemofili A: Hemofili A pıhtılaşma faktör VIII eksikliğiyle kanama eğilimi yapar; kronik hemoliz ve sferosit oluşturmaz. Bu olguda “Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.” ve “Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Herediter sferositoz seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Herediter sferositoz: Herediter sferositoz kronik hemoliz, splenomegali, yüksek MCHC ve sferositlerle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.” ve “Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Beta talasemi taşıyıcılığı: Beta talasemi taşıyıcılığı mikrositozla seyreder; yüksek MCHC ve belirgin sferositik hemoliz beklenmez. Bu olguda “Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.” ve “Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.” ipuçları tanısız karar açısından Herediter sferositoz seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Sarılık ve dalak büyüklüğü olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.” ve “Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.” birlikte okunduğunda Herediter sferositoz seçeneği öne çıkar; “MCHC yüksek ve periferik yaymada sferositler izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kronik ekstrasvasküler hemoliz, splenomegali, aile öyküsü, yüksek MCHC ve periferik yaymada sferositler herediter sferositozu düşündürür. Eritrosit membran iskeleti bozukluğu dalakta eritrositlerin yıkımını artırır ve pigment safra taşı riskini yükseltir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.”, “Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.” ve “MCHC yüksek ve periferik yaymada sferositler izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Herediter sferositoz en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Çocukta aralıklı sarılık, kronik anemi ve splenomegali vardır.

Kanıt 2: Ailede çocukluk döneminde safra taşı öyküsü bulunması kalıtsal hemolizi destekler.

Kanıt 3: MCHC yüksek ve periferik yaymada sferositler izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Herediter sferositozda MCHC yüksekliği ve sferositler önemli ipuçlarıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 400: v337-peds-clinical-unique-010-diz-agrisiyla-gelen-adolesan

Başlık: Diz ağrısıyla gelen adolesan

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Çocuk hastada tanıyı klinik ve objektif bulgularla ayırt etme.

Learning Target: Adolesanda slipped capital femoral epiphysis tablosunu obezite, kalça-diz ağrısı ve dış rotasyonla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, birkaç haftadır süren sağ diz ağrısı ve aksayarak yürüme nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun kilolu olduğunu, spor sonrası diz ağrısı tariflediğini ancak belirgin travma olmadığını belirtmektedir. Son günlerde merdiven inerken zorlanması artmış ve sağ ayağını dışa dönük basmaya başlamıştır. Ateş veya gece terlemesi yoktur.

Demografi: 13 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Çocuk obez görünümündedir ve antalgik yürür.
- Sağ kalçada iç rotasyon kısıtlıdır; kalça fleksiyonu sırasında uyluk dış rotasyona gitmektedir.
- Diz muayenesinde belirgin efüzyon yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Pelvis grafisi

Etiket: Pelvis grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Görüntüleme | Özet: Sağ femur başı epifizinde metafize göre kayma izlendi. | Klinik anlam: Slipped capital femoral epiphysis lehinedir. | Sonuç yorumu: Slipped capital femoral epiphysis lehinedir. | Sonuç başlığı: Pelvis grafisi | Sonuç özeti: Sağ femur başı epifizinde metafize göre kayma izlendi. | Yorum: Slipped capital femoral epiphysis lehinedir. | Satırlar: Pelvis grafisi / Sağ femur başı epifizinde metafize göre kayma izlendi. // Slipped capital femoral epiphysis lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Slipped capital femoral epiphysis
B) Septik artrit
C) Juvenil osteoporoz
D) Patellar tendinit
E) Osgood-Schlatter hastalığı

Doğru Cevap: Slipped capital femoral epiphysis

- A) Slipped capital femoral epiphysis: Slipped capital femoral epiphysis obez adolesanda aksama, kalça iç rotasyon kısıtlılığı ve epifiz kaymasıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.” ve “Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- B) Septik artrit: Septik artritte ateş, toksik görünüm ve şiddetli pasif hareket ağrısı beklenir; bu olguda kronik aksama ve epifiz kayması vardır. Bu olguda “Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.” ve “Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Slipped capital femoral epiphysis seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Juvenil osteoporoz: Juvenil osteoporoz yaygın kemik kırılabilirliğiyle ilişkilidir; femur başı epifiz kaymasını açıklamaz. Bu olguda “Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.” ve “Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Slipped capital femoral epiphysis seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) Patellar tendinit: Patellar tendinit ön diz tendon hassasiyetiyle seyreder; kalça grafisindeki epifiz kaymasıyla uyumlu değildir. Bu olguda “Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.” ve “Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Slipped capital femoral epiphysis seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Osgood-Schlatter hastalığı: Osgood-Schlatter hastalığı tibial tüberkül ağrısı ve aktivite ilişkili ön diz ağrısıyla seyreder; kalça rotasyon kısıtlılığı yapmaz. Bu olguda “Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.” ve “Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.” ipuçları tanısız karar açısından Slipped capital femoral epiphysis seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Diz ağrısıyla gelen adolesan olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.” ve “Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.” birlikte okunduğunda Slipped capital femoral epiphysis seçeneği öne çıkar; “Pelvis grafisinde femur başı epifiz kayması izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Kilolu adolesanda kalça kaynaklı diz ağrısı, aksama, kalça iç rotasyon kısıtlılığı ve grafide femur başı epifiz kayması slipped capital femoral epiphysis ile uyumludur. Diz ağrısı yansıyan ağrı olabilir; tanı gecikirse avasküler nekroz ve deformite riski artar. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.”, “Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.” ve “Pelvis grafisinde femur başı epifiz kayması izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Slipped capital femoral epiphysis en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Hasta obez adolesandır ve travma olmadan aksama gelişmiştir.

Kanıt 2: Diz ağrısına rağmen kalça iç rotasyonu kısıtlıdır ve dış rotasyon postürü vardır.

Kanıt 3: Pelvis grafisinde femur başı epifiz kayması izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Adolesanda diz ağrısı kalça patolojisinden yansıyabilir; SCFE için kalça muayenesi önemlidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 401: v339-peds-001-yenidoganda-kusma-ve-dolasim-bozuklugu

Başlık: Yenidoğanda kusma ve dolaşım bozukluğu

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Neonatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Tuz kaybettiren adrenal krizde hipoglisemi, hiponatremi, hiperkalemi ve şok bulgularıyla hidrokortizon önceliğini seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, tekrarlayan kusma, emmede azalma ve halsizlik nedeniyle acil servise getiriliyor. Ailesi bebeğin son iki gündür giderek daha az emdiğini, sık kusmaya başladığını ve bez sayısının azaldığını belirtmektedir. Doğumdan sonra dış genital yapısının farklı görüldüğü söylenmiş ancak ileri değerlendirme için henüz randevu alınamamıştır. Ateş, ishal veya bilinen doğumsal kalp hastalığı öyküsü yoktur.

Demografi: 14 günlük kız yenidoğan | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 62/36 mmHg | Nabız: 178/dk | Solunum: 18/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.2°C | Şok indeksi: 2,87 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve belirgin dehidrate görünmektedir.
- Kapiller dolum 4 saniyedir, periferik nabızları zayıftır.
- Dış genital yapıda klitoromegali ve posterior labial füzyon izlenir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum sodyum

Etiket: Serum sodyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Tuz kaybettiren mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum sodyum | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: Tuz kaybettiren mineralokortikoid eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum sodyum / 121 mmol/L / 135-145 mmol/L

Tetkik 2: Serum potasyum

Etiket: Serum potasyum | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Aldosteron eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: Serum potasyum | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Aldosteron eksikliğini destekler. | Satırlar: Serum potasyum / 6.8 mmol/L / 3.5-5.0 mmol/L

Tetkik 3: Kan glukozu

Etiket: Kan glukozu | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük saptandı. | Klinik anlam: Kortizol eksikliğiyle uyumludur. | Sonuç başlığı: Kan glukozu | Sonuç özeti: Düşük saptandı. | Yorum: Kortizol eksikliğiyle uyumludur. | Satırlar: Kan glukozu / 42 mg/dL / 70-100 mg/dL

Tetkik 4: 17-hidroksiprogesteron

Etiket: 17-hidroksiprogesteron | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin yüksek saptandı. | Klinik anlam: 21-hidroksilaz eksikliğini destekler. | Sonuç başlığı: 17-hidroksiprogesteron | Sonuç özeti: Belirgin yüksek saptandı. | Yorum: 21-hidroksilaz eksikliğini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte sıvı resüsitasyonu ile birlikte geciktirilmemesi gereken özgül acil tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sıvı resüsitasyonu ve hiperkalemi tedavisiyle yetinip steroid replasmanını endokrin değerlendirmeye bırakmak
- B) İntravenöz hidrokortizon başlamak
- C) Potasyum replasmanı yapmak
- D) Oral hidrokortizonla ayaktan tedavi denemek
- E) Fototerapi başlamak

Doğru Cevap: İntravenöz hidrokortizon başlamak

A) Sıvı resüsitasyonu ve hiperkalemi tedavisiyle yetinip steroid replasmanını endokrin değerlendirmeye bırakmak: İzotonik sıvı gereklidir ancak adrenal krizde tek başına yeterli değildir; kortizol eksikliği için hidrokortizon geciktirilmemelidir. Bu olguda “Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

B) İntravenöz hidrokortizon başlamak: İntravenöz hidrokortizon adrenal krizde kortizol eksikliğini hızla yerine koyan ve şok yönetiminde geciktirilmemesi gereken özgül tedavidir. Vakadaki “Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklidir.

C) Potasyum replasmanı yapmak: Vakadaki Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır ve Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır. Bu olguda “Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Oral hidrokortizonla ayaktan tedavi denemek: Yalnızca oral antiemetik vermek hipoglisemi, hiperkalemi ve şokla seyreden adrenal krizi tedavi etmez. Bu olguda “Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Fototerapi başlamak: Fototerapi hiperbilirubinemi tedavisidir; adrenal kriz, hipoglisemi ve elektrolit bozukluklarını düzeltmez. Bu olguda “Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.” ipuçları tedavi önceliği açısından İntravenöz hidrokortizon başlamak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekeç / Kanıt / Core

Klinik gerekeç: Yenidoğanda kusma ve dolaşım bozukluğu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.” ve “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.” birlikte okunduğunda İntravenöz hidrokortizon başlamak seçeneği öne çıkar; “Virilizasyon bulguları ve yüksek 17-hidroksiprogesteron 21-hidroksilaz eksikliğini desteklemektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda kusma, şok, hiponatremi, hiperkalemi, hipoglisemi ve virilizasyon tuz kaybettiren konjenital adrenal hiperplaziye bağlı adrenal krizi düşündürür. Dolaşım desteğiyle birlikte stres doz intravenöz hidrokortizon geciktirilmemelidir; mineralokortikoid eksikliği ve kortizol eksikliği yaşamı tehdit eder. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.”, “Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.” ve “Virilizasyon bulguları ve yüksek 17-hidroksiprogesteron 21-hidroksilaz eksikliğini desteklemektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İntravenöz hidrokortizon başlamak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Bebekte kusma, emmede azalma, hipotansiyon ve uzamış kapiller dolum vardır.

Kanıt 2: Hiponatremi, hiperkalemi ve hipoglisemi birlikte saptanmıştır.

Kanıt 3: Virilizasyon bulguları ve yüksek 17-hidroksiprogesteron 21-hidroksilaz eksikliğini desteklemektedir.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Tuz kaybettiren adrenal krizde sıvı ve dekstroz desteğiyle birlikte stres doz hidrokortizon acildir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 402: v339-peds-002-biloz-kusma-ve-batin-hassasiyeti

Başlık: Bilöz kusma ve batin hassasiyeti

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Neonatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Bilöz kusması olan yenidoğanda malrotasyon-volvulus şüphesini tanıyıp acil cerrahi değerlendirme seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, aniden başlayan yeşil renkli kusma, huzursuzluk ve beslenememe nedeniyle getiriliyor. Doğumdan sonra ilk günlerde beslendiği ve mekonyum çıkardığı öğreniliyor. Son 8 saatte birkaç kez parlak yeşil kusma olmuş, emmesi belirgin azalmış ve giderek huzursuzlaşmıştır. Ateş öyküsü yoktur; ailesi bebeğin bacaklarını karnına çekerek ağladığını belirtmektedir.

Demografi: 5 günlük kız yenidoğan | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 72/42 mmHg | Nabız: 166/dk | Solunum: 52/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 2,31 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek huzursuz ve soluk görünmektedir.
- Batin hafif distandü ve hassastır; belirgin peritonit bulgusu henüz yoktur.
- Kapiller dolum 3 saniyedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Direkt batin grafisi

Etiket: Direkt batin grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Belirgin distal gaz azalması ve üst abdominal gaz distansiyonu izlendi. | Klinik anlam: Üst intestinal obstrüksiyonu düşündürür. | Sonuç başlığı: Direkt batin grafisi | Sonuç özeti: Belirgin distal gaz azalması ve üst abdominal gaz distansiyonu izlendi. | Yorum: Üst intestinal obstrüksiyonu düşündürür.

Tetkik 2: Üst gastrointestinal kontrast çalışma

Etiket: Üst gastrointestinal kontrast çalışma | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Duodenojejunal bileşkenin normal sol üst kadranda yerleşiminde olmadığı ve tirbuşon görünümü izlendi. | Klinik anlam: Malrotasyon-volvulus lehinedir. | Sonuç başlığı: Üst gastrointestinal kontrast çalışma | Sonuç özeti: Duodenojejunal bileşkenin normal sol üst kadranda yerleşiminde olmadığı ve tirbuşon görünümü izlendi. | Yorum: Malrotasyon-volvulus lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu yenidoğanda en uygun acil yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nazogastrik dekompresyon sonrası üst gastrointestinal pasaj değerlendirmesini elektif şartlara bırakmak
- B) Hipertrofik pilor stenozu düşünerek elektif piloromiyotomi planlamak
- C) Kontrast lavmanla invajinasyon redüksiyonu denemek
- D) Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak
- E) Gastroözofageal reflü için kıvam artırıcı beslenme başlamak

Doğru Cevap: Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak

- A) Nazogastrik dekompresyon sonrası üst gastrointestinal pasaj değerlendirmesini elektif şartlara bırakmak: Dekompresyon ve sıvı desteği başlangıç stabilizasyonunda gereklidir ancak volvulus şüphesinde tek başına seri muayene iskemi riskini gidermek için yeterli değildir. Bu olguda “Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.” ve “Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Hipertrofik pilor stenozu düşünerek elektif piloromiyotomi planlamak: Pilor stenozu tipik olarak safrasız fışkırır kusma yapar; bu olguda bilöz kusma ve tirbuşon görünümü malrotasyon-volvulusu destekler. Bu olguda “Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.” ve “Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Kontrast lavmanla invajinasyon redüksiyonu denemek: Kontrast lavman invajinasyonda tedavi edici olabilir ancak yenidoğanda bilöz kusma ve duodenal yerleşim anomalisi volvulus lehinedir. Bu olguda “Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.” ve “Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereksizdir.
- D) Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak: Acil cerrahi değerlendirme malrotasyon-volvulusta bağırsak iskemisi ve nekrozunu önlemek için doğru yaklaşımdır. Vakadaki “Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.” ve “Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Gastroözofageal reflü için kıvam artırıcı beslenme başlamak: Reflü yönetimi bilöz kusma, batin hassasiyeti ve kontrast çalışmada tirbuşon görünümü olan yenidoğanda tehlikeli gecikmeye neden olur. Bu olguda “Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.” ve “Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.” ipuçları tedavi önceliği açısından Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bilöz kusma ve batin hassasiyeti olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.” ve “Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.” birlikte okunduğunda Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak seçeneği öne çıkar; “Üst gastrointestinal kontrast çalışmada duodenojejunal yerleşim anomalisi ve tirbuşon görünümü vardır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Yenidoğanda bilöz kusma aksi kanıtlanana kadar cerrahi acil kabul edilmelidir. Malrotasyon-volvulus bağırsak kan akımını hızla bozabileceği için nazogastrik dekompresyon, sıvı resüsitasyonu, antibiyotik ve acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.”, “Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.” ve “Üst gastrointestinal kontrast çalışmada duodenojejunal yerleşim anomalisi ve tirbuşon görünümü vardır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Acil çocuk cerrahisi değerlendirmesi ve volvulus-iskemiye yönelik hazırlık yapmak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Bebekte parlak yeşil bilöz kusma aniden başlamıştır.

Kanıt 2: Batin hassasiyeti, huzursuzluk ve perfüzyon bozulması erken iskemi riskini düşündürmektedir.

Kanıt 3: Üst gastrointestinal kontrast çalışmada duodenojejunal yerleşim anomalisi ve tirbuşon görünümü vardır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: Yenidoğanda bilöz kusma cerrahi obstrüksiyon açısından acildir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 403: v339-peds-003-premature-bebekte-batin-distansiyonu

Başlık: Prematüre bebekte batin distansiyonu

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Neonatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Acil

Klinik Hedef: Acil öncelik ve tedavi güvenliğini birlikte değerlendirme.

Learning Target: Prematüre bebekte nekrotizan enterokolit bulgularıyla enteral beslenmenin kesilmesi ve antibiyotik yaklaşımını seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, enteral beslenme artırıldıktan sonra gelişen batin distansiyonu, rezidü artışı ve kanlı dışkı nedeniyle izleniyor. Otuz haftalık prematüre doğduğu, son günlerde anne sütü ve formül karışımı ile beslenme hacminin artırıldığı öğreniliyor. Son 12 saatte apne atakları, letarji ve gastrik rezidü artışı gelişmiştir. Daha önce barsak cerrahisi geçirmemiştir.

Demografi: 12 günlük prematüre erkek bebek | Setting: Yenidoğan yoğun bakım

Vital Bulgular

Kan basıncı: 94/58 mmHg | Nabız: 172/dk | Solunum: 30/dk | SpO₂: %97% | Ateş: 36.1°C | Şok indeksi: 1,83 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek letarjik ve soluk görünmektedir.
- Batin belirgin distandü ve hassastır; bağırsak sesleri azalmıştır.
- Kapiller dolum 4 saniyedir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Direkt batin grafisi

Etiket: Direkt batin grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Bağırsak duvarında pnömatozis intestinalis ile uyumlu hava izlenimleri saptandı. | Klinik anlam: Nekrotizan enterokolit için tipiktir. | Sonuç başlığı: Direkt batin grafisi | Sonuç özeti: Bağırsak duvarında pnömatozis intestinalis ile uyumlu hava izlenimleri saptandı. | Yorum: Nekrotizan enterokolit için tipiktir.

Tetkik 2: Tam kan sayımı

Etiket: Tam kan sayımı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Trombositopeni ve lökosit sayısında düzensizlik saptandı. | Klinik anlam: Sistemik hastalık ağırlığını destekler. | Sonuç başlığı: Tam kan sayımı | Sonuç özeti: Trombositopeni ve lökosit sayısında düzensizlik saptandı. | Yorum: Sistemik hastalık ağırlığını destekler.

Tetkik 3: Kan gazı

Etiket: Kan gazı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Metabolik asidoz saptandı. | Klinik anlam: Doku hipoperfüzyonu ve ağır hastalığı destekler. | Sonuç başlığı: Kan gazı | Sonuç özeti: Metabolik asidoz saptandı. | Yorum: Doku hipoperfüzyonu ve ağır hastalığı destekler. | Satırlar: Kan gazı / pH 7.24, HCO₃ 15 mmol/L /

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte en uygun başlangıç tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Enteral beslenmeyi azaltıp antibiyotığı seri grafide kötüleşme olursa başlamak
- B) Mekonyum ileusu düşünerek gastrografen lavmanını ilk ve tek tedavi olarak uygulamak
- C) Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak
- D) Probiyotik ve beslenme düzenlemesiyle medikal konservatif izlem yapmak
- E) Rutin fototerapi başlamak

Doğru Cevap: Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak

A) Enteral beslenmeyi azaltıp antibiyotığı seri grafide kötüleşme olursa başlamak: Beslenmeyi sürdürmek pnömatozis ve sistemik kötüleşme olan NEK tablosunda barsak distansiyonu ve perforasyon riskini artırır. Bu olguda “Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.” ve “Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Mekonyum ileusu düşünerek gastrografen lavmanını ilk ve tek tedavi olarak uygulamak: Mekonyum ileusu farklı bir neonatal obstrüksiyon nedenidir; bu olguda prematürite, kanlı dışkı ve pnömatozis intestinalis NEK lehinedir. Bu olguda “Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.” ve “Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak: Beslenmenin kesilmesi, dekompresyon, intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem nekrotizan enterokolit başlangıç yönetiminin temelidir. Vakadaki “Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.” ve “Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

D) Probiyotik ve beslenme düzenlemesiyle medikal konservatif izlem yapmak: Probiyotikler koruyucu bağlamda tartışılabilir ancak ağır sistemik bulguları ve pnömatozis intestinalisi olan bebekte tedavinin yerine geçmez. Bu olguda “Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.” ve “Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Rutin fototerapi başlamak: Fototerapi hiperbilirubinemi tedavisidir; batin distansiyonu, kanlı dışkı ve pnömatozis intestinalisi düzelmez. Bu olguda “Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.” ve “Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.” ipuçları tedavi önceliği açısından Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Prematüre bebekte batin distansiyonu olgusunda klinik karar tedavi önceliği üzerine kuruludur. “Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.” ve “Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.” birlikte okunduğunda Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak seçeneği öne çıkar; “Grafide pnömatozis intestinalis saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Prematüre bebekte enteral beslenme sonrası batin distansiyonu, kanlı dışkı, sistemik kötüleşme ve grafide pnömatozis intestinalis nekrotizan enterokoliti düşündürür. Tedavide barsak istirahati, nazogastrik dekompresyon, geniş spektrumlu antibiyotik, sıvı-dolaşım desteği ve perforasyon açısından cerrahi izlem gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.”, “Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.” ve “Grafide pnömatozis intestinalis saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Enteral beslenmeyi kesmek, nazogastrik dekompresyon yapmak, geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik ve cerrahi izlem başlatmak en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Bebek prematüre ve enteral beslenme artırılması sonrası kötüleşmiştir.

Kanıt 2: Batin distansiyonu, kanlı dışkı ve sistemik letarji vardır.

Kanıt 3: Grafide pnömatozis intestinalis saptanmıştır.

Core Knowledge: Tedavi önceliği sorularında doğru yanıt, tanıyı bilmekten çok hangi müdahalenin ilk dakikalarda morbidite veya mortaliteyi azalttığını seçmeye dayanır. Hava yolu, dolaşım, ağır elektrolit bozukluğu, sepsis veya organ iskemisi varsa destekleyici ve geç etkili tedaviler ilk basamağın yerine geçmez.

Exam Pearl: NEK’te pnömatozis intestinalis klasik radyolojik bulgudur; beslenme kesilir ve antibiyotik başlanır.

VAKA 404: v339-peds-004-grip-sonrası-kusma-ve-bilinc-degisikligi

Başlık: Grip sonrası kusma ve bilinç değişikliği

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Metabolizma | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik bulgular ve tetkik verileriyle olası tanıyı belirleme.

Learning Target: Viral hastalık sonrası aspirin maruziyetiyle gelişen Reye sendromunu hiperammonemi ve hepatik disfonksiyonla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, viral hastalık sonrası tekrarlayan kusma, davranış değişikliği ve uykuya eğilim nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun birkaç gün önce ateşli grip benzeri hastalık geçirdiğini ve ateş için evde aspirin içeren bir ilaç verildiğini belirtmektedir. Ateşi gerilemişken son 24 saatte inatçı kusma, huzursuzluk, ardından konfüzyon ve uykuya eğilim başlamıştır. Travma veya bilinen metabolik hastalık öyküsü yoktur.

Demografi: 6 yaşında erkek çocuk | Setting: Çocuk acil servisi

Vital Bulgular

Kan basıncı: 104/66 mmHg | Nabız: 118/dk | Solunum: 22/dk | SpO₂: %98% | Ateş: 38.3°C | Şok indeksi: 1,13 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk letarjik ve iritabldır.
- Ense sertliği belirgin değildir.
- Karaciğer hafif büyümüş palpe edilir.
- Sarılık belirgin değildir.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Serum amonyak

Etiket: Serum amonyak | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hepatik mitokondriyal disfonksiyonu destekler. | Sonuç başlığı: Serum amonyak | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hepatik mitokondriyal disfonksiyonu destekler. | Satırlar: Serum amonyak / 162 µmol/L / <50 µmol/L

Tetkik 2: AST/ALT

Etiket: AST/ALT | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Hepatoselüler hasarı destekler. | Sonuç başlığı: AST/ALT | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Hepatoselüler hasarı destekler. | Satırlar: AST/ALT / AST 420, ALT 390 U/L /

Tetkik 3: Bilirubin

Etiket: Bilirubin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal-sınırda yakın saptandı. | Klinik anlam: Belirgin kolestatik sarılık olmadığını gösterir. | Sonuç başlığı: Bilirubin | Sonuç özeti: Normal-sınırda yakın saptandı. | Yorum: Belirgin kolestatik sarılık olmadığını gösterir. | Satırlar: Bilirubin / 1.1 mg/dL / 0.2-1.2 mg/dL

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Viral ensefalit
B) Asetaminofen toksisitesine bağlı akut karaciğer yetmezliği
C) Üre döngüsü defekti
D) Bakteriyel menenjit
E) Reye sendromu

Doğru Cevap: Reye sendromu

A) Viral ensefalit: Viral ensefalit bilinç değişikliği yapabilir ancak aspirin maruziyeti, hiperammonemi ve belirgin sarılık olmadan transaminaz yüksekliği Reye sendromunu daha güçlü destekler. Bu olguda “Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.” ve “Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Reye sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Asetaminofen toksisitesine bağlı akut karaciğer yetmezliği: Asetaminofen toksisitesinde ilaç alım öyküsü ve ağır hepatoselüler nekroz beklenir; bu olguda aspirin sonrası viral hastalık paternine vurgu yapılmıştır. Bu olguda “Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.” ve “Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Reye sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Üre döngüsü defekti: Üre döngüsü defekti hiperammonemi yapabilir ancak daha erken yaşta protein alımıyla tetiklenen ataklar beklenir; aspirin sonrası viral hastalık öyküsü ayırcıdır. Bu olguda “Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.” ve “Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Reye sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Bakteriyel menenjit: Bakteriyel menenjit ateş, ense sertliği ve BOS bulgularıyla desteklenmelidir; burada hepatik disfonksiyon ve hiperammonemi ön plandadır. Bu olguda “Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.” ve “Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.” ipuçları tanısız karar açısından Reye sendromu seçeneğini daha güçlü kılar.

E) Reye sendromu: Reye sendromu viral hastalık sonrası aspirin maruziyeti, kusma, ensefalopati ve hiperammonemiyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.” ve “Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gereklendir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Grip sonrası kusma ve bilinç değişikliği olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.” ve “Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.” birlikte okunduğunda Reye sendromu seçeneği öne çıkar; “Amonyak ve transaminazlar yüksekken belirgin sarılık yoktur.” ise ayırcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Viral hastalık sonrası aspirin maruziyeti, inatçı kusma, ensefalopati, hiperammonemi ve transaminaz yüksekliği Reye sendromunu düşündürür. Temel patoloji mitokondriyal hepatik disfonksiyon ve mikroveziküler yağlanmadır; çocuklarda viral enfeksiyonda aspirin kullanımından kaçınılır. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.”, “Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.” ve “Amonyak ve transaminazlar yüksekken belirgin sarılık yoktur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Reye sendromu en tutarlı yanittir.

Kanıt 1: Çocuk viral hastalık sırasında aspirin içeren ilaç kullanmıştır.

Kanıt 2: Ateş gerilerken kusma ve bilinç değişikliği gelişmiştir.

Kanıt 3: Amonyak ve transaminazlar yüksekken belirgin sarılık yoktur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtı ayrılar.

Exam Pearl: Viral enfeksiyon geçiren çocukta aspirin kullanımı Reye sendromu riski nedeniyle sakıncalıdır.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 405: v339-peds-005-viral-enfeksiyon-sonrasi-morarma

Başlık: Viral enfeksiyon sonrası morarma

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Hematoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Klinik bulgular ve tetkik verileriyle olası tanıyı belirleme.

Learning Target: Çocukta immün trombositopeniyi viral enfeksiyon sonrası izole trombositopeni ve peteşiyle tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, bacaklarda morarma ve burun kanaması sonrası fark edilen peteşiler nedeniyle getiriliyor. Ailesi çocuğun iki hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini, sonrasında bacaklarda noktasal döküntüler ve kolay morarma başladığını belirtmektedir. Uzamış ateş, kilo kaybı, gece terlemesi, kemik ağrısı veya tekrarlayan ciddi enfeksiyon öyküsü yoktur.

Demografi: 4 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 88/54 mmHg | Nabız: 122/dk | Solunum: 24/dk | SpO₂: %96% | Ateş: 36.8°C | Şok indeksi: 1,39 (yüksek)

Fizik Muayene

- Çocuk iyi görünümündür.
- Alt ekstremitelerde peteşi ve ekimozlar vardır.
- Lenfadenopati, hepatomegali ve splenomegali saptanmaz.
- Nörolojik muayenesi doğaldır.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Trombosit sayısı

Etiket: Trombosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: İzole trombositopeniyi gösterir. | Sonuç başlığı: Trombosit sayısı | Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: İzole trombositopeniyi gösterir. | Satırlar: Trombosit sayısı / 18000 /mm³ / 150000-450000 /mm³

Tetkik 2: Hemogloblin

Etiket: Hemogloblin | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Ek seri etkilenimi olmadığını destekler. | Sonuç başlığı: Hemogloblin | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Ek seri etkilenimi olmadığını destekler. | Satırlar: Hemogloblin / 12.1 g/dL /

Tetkik 3: Lökosit sayısı

Etiket: Lökosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Normal saptandı. | Klinik anlam: Kemik iliği yetmezliği bulgusunu geri plana iter. | Sonuç başlığı: Lökosit sayısı | Sonuç özeti: Normal saptandı. | Yorum: Kemik iliği yetmezliği bulgusunu geri plana iter. | Satırlar: Lökosit sayısı / 7600 /mm³ /

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akut lösemi
B) Hemofili A
C) İmmün trombositopeni
D) Von Willebrand hastalığı
E) Aplastik anemi

Doğru Cevap: İmmün trombositopeni

- A) Akut lösemi: Akut lösemide anemi, lökosit anormallliği, blast, kemik ağrısı veya organomegali beklenebilir; bu olguda izole trombositopeni vardır. Bu olguda “Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.” ipuçları tanısız karar açısından İmmün trombositopeni seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Hemofili A: Hemofili A koagülasyon faktör VIII eksikliğine bağlı derin doku ve eklem kanamaları yapar; izole trombositopeni beklenmez. Bu olguda “Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.” ipuçları tanısız karar açısından İmmün trombositopeni seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) İmmün trombositopeni: İmmün trombositopeni viral enfeksiyon sonrası gelişen peteşi-ekimoz ve izole trombositopeniyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- D) Von Willebrand hastalığı: Von Willebrand hastalığı mukozal kanama yapabilir ancak trombosit sayısı genellikle normaldir; bu olguda belirgin izole trombositopeni vardır. Bu olguda “Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.” ipuçları tanısız karar açısından İmmün trombositopeni seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Aplastik anemi: Aplastik anemi çoklu hücre serilerinde azalma yapar; hemogloblin ve lökositin normal olması bu tanıyı desteklemez. Bu olguda “Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.” ipuçları tanısız karar açısından İmmün trombositopeni seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Viral enfeksiyon sonrası morarma olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.” ve “Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.” birlikte okunduğunda İmmün trombositopeni seçeneği öne çıkar; “Lenfadenopati, hepatomegali ve splenomegali saptanmamıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Viral enfeksiyon sonrası iyi görünümlü çocukta peteşi-ekimoz, organomegali olmaması ve hemogloblin-lökosit normal iken izole trombositopeni immün trombositopeniyi düşündürür. Akut lösemi gibi kemik iliği hastalıklarında genellikle ek sitopeniler, blast, organomegali veya sistemik bulgular beklenir. Bu olguda kararın temel ayırımı, “Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.”, “Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.” ve “Lenfadenopati, hepatomegali ve splenomegali saptanmamıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle İmmün trombositopeni en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Peteşi ve morarma üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlamıştır.

Kanıt 2: Trombosit sayısı belirgin düşükken hemogloblin ve lökosit normaldir.

Kanıt 3: Lenfadenopati, hepatomegali ve splenomegali saptanmamıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: ITP’de temel bulgu izole trombositopenidir; organomegali ve çoklu sitopeni alternatif tanıları düşündürür.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 406: v339-peds-006-bebekte-tekrarlayan-agir-enfeksiyon

Başlık: Bebekte tekrarlayan ağır enfeksiyon

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / İmmünoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik bulgular ve tetkik verileriyle olası tanıyı belirleme.

Learning Target: Ağır kombine immün yetmezlikte erken ağır enfeksiyonlar, lenfopeni ve timus yokluğuyla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, tekrarlayan pnömoni, kronik ishal ve ağız içinde geçmeyen mantar enfeksiyonu nedeniyle getiriliyor. Ailesi bebeğin doğumdan sonra ilk aylardan itibaren sık hastalandığını, iki kez hastaneye yatış gerektiren akciğer enfeksiyonu geçirdiğini ve kilo alımının çok yavaş olduğunu belirtmektedir. Canlı aşı sonrası uzamış lokal reaksiyon öyküsü de sorgulanmaktadır. Akraba evliliği vardır.

Demografi: 5 aylık erkek bebek | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Kan basıncı: 86/54 mmHg | Nabız: 132/dk | Solunum: 28/dk | SpO₂: %91% | Ateş: 38.0°C | Şok indeksi: 1,53 (yüksek)

Fizik Muayene

- Bebek zayıf ve gelişme geriliği olan görünümde, oral kandidiyazisi belirgindir.
- Akciğerlerde yaygın ince raller duyulur.
- Lenf nodları belirgin palpe edilmez, tonsiller küçük görünür.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Mutlak lenfosit sayısı

Etiket: Mutlak lenfosit sayısı | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: T hücre yetmezliğini düşündürür. | Sonuç başlığı: Mutlak lenfosit sayısı |

Sonuç özeti: Belirgin düşük saptandı. | Yorum: T hücre yetmezliğini düşündürür. | Satırlar: Mutlak lenfosit sayısı / 650 /mm³ / Yaşa göre beklenenin belirgin altında

Tetkik 2: Akciğer grafisi

Etiket: Akciğer grafisi | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Timus gölgesi izlenmedi. | Klinik anlam: Hücresel immün yetmezlik lehine bulgudur. | Sonuç başlığı: Akciğer grafisi | Sonuç özeti: Timus gölgesi izlenmedi. | Yorum: Hücresel immün yetmezlik lehine bulgudur.

Tetkik 3: Lenfosit alt grup analizi

Etiket: Lenfosit alt grup analizi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: T hücre sayısı belirgin düşük saptandı. | Klinik anlam: Ağır kombine immün yetmezliği destekler. | Sonuç başlığı: Lenfosit alt grup analizi | Sonuç özeti: T hücre sayısı belirgin düşük saptandı. | Yorum: Ağır kombine immün yetmezliği destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Selektif IgA eksikliği
B) X'e bağlı agammaglobulinemi
C) Kronik granüloamatöz hastalık
D) Ağır kombine immün yetmezlik
E) Wiskott-Aldrich sendromu

Doğru Cevap: Ağır kombine immün yetmezlik

A) Selektif IgA eksikliği: Selektif IgA eksikliği daha hafif mukozal enfeksiyonlarla seyreder; ağır T hücre lenfopenisi ve timus yokluğu beklenmez. Bu olguda “Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.” ve “Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Ağır kombine immün yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.

B) X'e bağlı agammaglobulinemi: X'e bağlı agammaglobulinemide B hücre ve immüno globulin eksikliği baskındır; timus yokluğu ve ağır T hücre düşüklüğü SCID lehinedir. Bu olguda “Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.” ve “Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Ağır kombine immün yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Kronik granüloamatöz hastalık: Kronik granüloamatöz hastalık katalaz pozitif enfeksiyonlar ve abse eğilimi yapar; belirgin T hücre lenfopenisi ve timus yokluğu beklenmez. Bu olguda “Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.” ve “Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Ağır kombine immün yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Ağır kombine immün yetmezlik: Ağır kombine immün yetmezlik erken ağır enfeksiyonlar, kandidiyazis, lenfopeni ve timus yokluğu ile en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.” ve “Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Wiskott-Aldrich sendromu: Wiskott-Aldrich sendromunda egzama ve mikrotrombositopeni beklenir; bu olguda ana patern T hücre lenfopenisi ve timus yokluğudur. Bu olguda “Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.” ve “Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.” ipuçları tanısız karar açısından Ağır kombine immün yetmezlik seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Bebekte tekrarlayan ağır enfeksiyon olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.” ve “Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.” birlikte okunduğunda Ağır kombine immün yetmezlik seçeneği öne çıkar; “Lenfosit sayısı ve T hücreleri belirgin düşük, timus gölgesi yoktur.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Erken bebeklikte fırsatçı enfeksiyonlar, kronik ishal, oral kandidiyazis, gelişme geriliği, lenfopeni, T hücre düşüklüğü ve timus gölgesinin olmaması ağır kombine immün yetmezliği düşündürür. Canlı aşılar tehlikeli olabilir; erken izolasyon, enfeksiyon tedavisi ve hematopoetik kök hücre nakli değerlendirmesi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.”, “Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.” ve “Lenfosit sayısı ve T hücreleri belirgin düşük, timus gölgesi yoktur.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Ağır kombine immün yetmezlik en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Bebekte erken aylardan itibaren ağır ve tekrarlayan enfeksiyonlar vardır.

Kanıt 2: Oral kandidiyazis, kronik ishal ve gelişme geriliği eşlik etmektedir.

Kanıt 3: Lenfosit sayısı ve T hücreleri belirgin düşük, timus gölgesi yoktur.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: SCID’de canlı aşılar kontrendikedir ve kesin tedavi için erken kök hücre nakli değerlendirilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 407: v339-peds-007-fotografta-beyaz-pupilla

Başlık: Fotoğrafta beyaz pupilla

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Göz Hastalıkları | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik bulgular ve tetkik verileriyle olası tanıyı belirleme.

Learning Target: Retinoblastomu lökokeri ve şaşılık bulgusuyla tanıyıp acil göz onkolojisi değerlendirmesi seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, aile fotoğraflarında sağ göz bebeğinin beyaz görünmesi ve son haftalarda gelişen içe kayma nedeniyle getiriliyor. Ailesi flaşlı fotoğraflarda sağ pupillada kırmızı yansıma yerine beyaz yansıma fark ettiğini, çocuğun bazen oyuncakları sağ tarafla takip etmekte zorlandığını belirtmektedir. Travma, ateş veya gözde akıntı öyküsü yoktur. Ailede çocukluk çağı göz tümörü öyküsü bilinmemektedir. Demografi: 18 aylık kız çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Sağ gözde lökokeri ve hafif şaşılık vardır.
- Korneada akut enfeksiyon bulgusu yoktur.
- Sol göz kırmızı refleksi normaldir.
- Sistemik muayenede belirgin lenfadenopati veya hepatosplenomegali saptanmaz.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Dilate fundus muayenesi

Etiket: Dilate fundus muayenesi | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Sağ retinada kalsifik odaklar içeren kitle görünümü izlendi. | Klinik anlam: Retinoblastom açısından şüphelidir. | Sonuç başlığı: Dilate fundus muayenesi | Sonuç özeti: Sağ retinada kalsifik odaklar içeren kitle görünümü izlendi. | Yorum: Retinoblastom açısından şüphelidir.

Tetkik 2: Orbital manyetik rezonans görüntüleme

Etiket: Orbital manyetik rezonans görüntüleme | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Optik sinir invazyonunu değerlendirmek amacıyla planlandı. | Klinik anlam: Yayılım ve tedavi planı için gereklidir. | Sonuç başlığı: Orbital manyetik rezonans görüntüleme | Sonuç özeti: Optik sinir invazyonunu değerlendirmek amacıyla planlandı. | Yorum: Yayılım ve tedavi planı için gereklidir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Konjenital katarakt
B) Coats hastalığı
C) Retinoblastom
D) Oküler toksokariasis
E) Persistan fetal vaskülarite

Doğru Cevap: Retinoblastom

- A) Konjenital katarakt: Konjenital katarakt lökokeri yapabilir ancak fundusta kalsifik retinal kitle ve şaşılık retinoblastomu daha güçlü destekler. Bu olguda “Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.” ve “Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Retinoblastom seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Coats hastalığı: Coats hastalığı lökokeri ayırıcı tanısındadır ancak genellikle eksüdatif retinopati paternindedir; kalsifik retinal kitle tipik değildir. Bu olguda “Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.” ve “Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Retinoblastom seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Retinoblastom: Retinoblastom lökokeri, şaşılık ve kalsifik retinal kitle bulgularıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.” ve “Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.
- D) Oküler toksokariasis: Oküler toksokariasis granülatöz retinal lezyon yapabilir ancak bu olguda yaş, lökokeri ve kalsifik kitle retinoblastom lehinedir. Bu olguda “Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.” ve “Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Retinoblastom seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Persistan fetal vaskülarite: Persistan fetal vaskülarite lökokeri yapabilir fakat kalsifik retinal tümör görünümü ve progresif şaşılık retinoblastomu daha olası kılar. Bu olguda “Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.” ve “Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Retinoblastom seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Fotoğrafta beyaz pupilla olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.” ve “Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Retinoblastom seçeneği öne çıkar; “Fundus muayenesinde kalsifik odaklar içeren retinal kitle izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Küçük çocukta lökokeri, şaşılık ve retinada kalsifik kitle retinoblastomu düşündürür. Tanı gecikirse optik sinir ve ekstraoküler yayılım riski artar; acil çocuk göz onkolojisi değerlendirmesi gerekir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.”, “Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.” ve “Fundus muayenesinde kalsifik odaklar içeren retinal kitle izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Retinoblastom en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Aile fotoğraflarında beyaz pupilla yansıması fark etmiştir.

Kanıt 2: Muayenede lökokeri ve şaşılık saptanmıştır.

Kanıt 3: Fundus muayenesinde kalsifik odaklar içeren retinal kitle izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Çocukta lökokeri aksi kanıtlanana kadar retinoblastom açısından acil değerlendirilmelidir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 408: v339-peds-008-kas-gucsuzlugu-ve-goz-cevresinde-mor-dokuntu

Başlık: Kas güçsüzlüğü ve göz çevresinde mor döküntü

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Romatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik bulgular ve tetkik verileriyle olası tanıyı belirleme.

Learning Target: Juvenil dermatomiyozitte proksimal kas güçsüzlüğü ve karakteristik deri bulgularıyla tanıyı seçebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, merdiven çıkmada zorlanma, saç tarayamama ve göz çevresinde mor-kızıl döküntü nedeniyle getiriliyor. Ailesi son iki aydır çocuğun yerden kalkarken zorlandığını, oyun sırasında çabuk yorulduğunu ve üst kollarını kaldırmakta güçlük çektiğini belirtmektedir. Döküntünün güneşle belirginleştiği, ateşin aralıklı ve düşük dereceli olduğu öğreniliyor. Yutma güçlüğü henüz belirgin değildir. Demografi: 8 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Göz kapaklarında heliotrop döküntü, parmak eklemlerinin ekstansör yüzlerinde Gottron papülleri vardır.
- Proksimal kas gücü özellikle omuz ve kalça kuşağında azalmıştır.
- Distal kas gücü görece korunmuştur.
- Eklemlerde belirgin efüzyon yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kreatin kinaz

Etiket: Kreatin kinaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Kas inflamasyonu ve hasarını destekler. | Sonuç başlığı: Kreatin kinaz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Kas inflamasyonu ve hasarını destekler. | Satırlar: Kreatin kinaz / 2360 U/L /

Tetkik 2: Aldolaz

Etiket: Aldolaz | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Miyopatiyi destekler. | Sonuç başlığı: Aldolaz | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Miyopatiyi destekler.

Tetkik 3: Kas manyetik rezonans görüntüleme

Etiket: Kas manyetik rezonans görüntüleme | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Proksimal kas gruplarında ödem sinyali izlendi. | Klinik anlam: İnflamatuvar miyozit lehinedir. | Sonuç başlığı: Kas manyetik rezonans görüntüleme | Sonuç özeti: Proksimal kas gruplarında ödem sinyali izlendi. | Yorum: İnflamatuvar miyozit lehinedir.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Duchenne musküler distrofisi
B) Sistemik lupus eritematozus
C) Juvenil idiyopatik artrit
D) Juvenil dermatomiyozit
E) Metabolik miyopati

Doğru Cevap: Juvenil dermatomiyozit

A) Duchenne musküler distrofisi: Duchenne musküler distrofisi erkek çocuklarda genetik distrofin bozukluğuyla seyreder; heliotrop döküntü ve Gottron papülleri beklenmez. Bu olguda “Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.” ve “Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Juvenil dermatomiyozit seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Sistemik lupus eritematozus: Sistemik lupus eritematozus döküntü ve sistemik bulgular yapabilir ancak Gottron papülleri, proksimal miyozit ve kas enzim yüksekliği dermatomiyoziti destekler. Bu olguda “Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.” ve “Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Juvenil dermatomiyozit seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Juvenil idiyopatik artrit: Juvenil idiyopatik artritte kronik eklem inflamasyonu ön plandadır; bu olguda objektif proksimal kas güçsüzlüğü ve miyozit bulguları vardır. Bu olguda “Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.” ve “Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Juvenil dermatomiyozit seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Juvenil dermatomiyozit: Juvenil dermatomiyozit proksimal güçsüzlük, heliotrop döküntü, Gottron papülleri ve yüksek kas enzimleriyle en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.” ve “Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Metabolik miyopati: Metabolik miyopati egzersiz intoleransı yapabilir ancak tipik heliotrop döküntü ve Gottron papülleri inflamatuvar dermatomiyozit lehinedir. Bu olguda “Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.” ve “Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.” ipuçları tanısız karar açısından Juvenil dermatomiyozit seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Kas güçsüzlüğü ve göz çevresinde mor döküntü olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.” ve “Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.” birlikte okunduğunda Juvenil dermatomiyozit seçeneği öne çıkar; “Kreatin kinaz ve aldolaz yüksek, kas MRG’inde ödem izlenmiştir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Proksimal simetrik kas güçsüzlüğü, heliotrop döküntü, Gottron papülleri, kas enzim yüksekliği ve MRG’de kas ödemi juvenil dermatomiyoziti düşündürür. Hastalık çocukluk çağının inflamatuvar miyopatisidir ve deri-kas tutulumu birlikte değerlendirilmelidir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.”, “Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.” ve “Kreatin kinaz ve aldolaz yüksek, kas MRG’inde ödem izlenmiştir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Juvenil dermatomiyozit en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Çocukta omuz ve kalça kuşağında proksimal kas güçsüzlüğü vardır.

Kanıt 2: Heliotrop döküntü ve Gottron papülleri saptanmıştır.

Kanıt 3: Kreatin kinaz ve aldolaz yüksek, kas MRG’inde ödem izlenmiştir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Juvenil dermatomiyozitte deri bulguları kas güçsüzlüğünden önce veya birlikte ortaya çıkabilir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 409: v339-peds-009-yenidogan-taramasinda-metabolik-risk

Başlık: Yenidoğan taramasında metabolik risk

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Neonatoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Orta

Klinik Hedef: Bulguların altında yatan mekanizmayı neden-sonuç ilişkisiyle ayırt etme.

Learning Target: Fenilketonüride fenilalanin hidroksilaz bozukluğunu diyet tedavisiyle ilişkilendirebilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Bebek, yenidoğan taramasında fenilalanin düzeyi yüksek saptandığı için ailesiyle birlikte getiriliyor. Ailesi bebeğin şu ana kadar belirgin şikâyeti olmadığını ancak son günlerde hafif kusma ve huzursuzluk fark ettiklerini belirtmektedir. Akraba evliliği vardır. Daha önce ailede nedeni bilinmeyen gelişim geriliği olan bir çocuk öyküsü sorgulanmaktadır.

Demografi: 21 günlük erkek bebek | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Bebek genel olarak iyi görünmektedir.
- Hafif iritabilite vardır.
- Cilt ve saç rengi aile bireylerine göre daha açık görünmektedir.
- Nörolojik muayenede belirgin fokal bulgu yoktur.
- Hemodinamik instabilite düşündüren belirgin klinik bulgu yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Plazma fenilalanin düzeyi

Etiket: Plazma fenilalanin düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Yüksek saptandı. | Klinik anlam: Fenilketonüri taramasını destekler. | Sonuç başlığı: Plazma fenilalanin düzeyi | Sonuç özeti: Yüksek saptandı. | Yorum: Fenilketonüri taramasını destekler.

Tetkik 2: Tirozin düzeyi

Etiket: Tirozin düzeyi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Düşük-normal saptandı. | Klinik anlam: Fenilalaninin tirozine dönüşümünde bozukluğu destekler. | Sonuç başlığı: Tirozin düzeyi | Sonuç özeti: Düşük-normal saptandı. | Yorum: Fenilalaninin tirozine dönüşümünde bozukluğu destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu hastalıkta temel biyokimyasal bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz aktivitesinde azalma
B) Branched-chain alfa-ketoasit dehidrogenaz aktivitesinde azalma
C) Tirozin aminotransferaz aktivitesinde azalma
D) Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma
E) Heksozaminidaz A aktivitesinde azalma

Doğru Cevap: Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma

A) Galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz aktivitesinde azalma: Galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz azalması galaktozemiye yol açar; fenilalanin yüksekliği ve tirozin düşüklüğünü açıklamaz. Bu olguda “Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.” ve “Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma seçeneğini daha güçlü kılar.

B) Branched-chain alfa-ketoasit dehidrogenaz aktivitesinde azalma: Branched-chain alfa-ketoasit dehidrogenaz azalması akçaağaç şurubu idrar hastalığıyla ilişkilidir; fenilalanin metabolizması bozukluğu değildir. Bu olguda “Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.” ve “Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma seçeneğini daha güçlü kılar.

C) Tirozin aminotransferaz aktivitesinde azalma: Tirozin aminotransferaz azalması tirozinemi tip II ile ilişkilidir; yenidoğan taramasında fenilalanin yüksekliği için temel açıklama değildir. Bu olguda “Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.” ve “Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma seçeneğini daha güçlü kılar.

D) Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma: Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma fenilalanin birikimini ve tirozin azalmasını açıklayan temel bozukluktur. Vakadaki “Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.” ve “Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

E) Heksozaminidaz A aktivitesinde azalma: Heksozaminidaz A azalması Tay-Sachs hastalığıyla ilişkilidir; fenilalaninin tirozine dönüşümüyle ilişkili değildir. Bu olguda “Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.” ve “Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.” ipuçları klinik karar açısından Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma seçeneğini daha güçlü kılar.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Yenidoğan taramasında metabolik risk olgusunda klinik karar klinik karar üzerine kuruludur. “Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.” ve “Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.” birlikte okunduğunda Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma seçeneği öne çıkar; “Tirozin düzeyinin düşük-normal olması dönüşüm basamağındaki bozukluğu desteklemektedir.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Fenilketonüri çoğunlukla fenilalanin hidroksilaz eksikliğine bağlıdır; fenilalanin tirozine dönüştürülemez ve nörotoksik metabolitler birikir. Erken fenilalanin kısıtlı diyet ve yeterli tirozin desteği nörogelişimsel hasarı önlemek için kritiktir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.”, “Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.” ve “Tirozin düzeyinin düşük-normal olması dönüşüm basamağındaki bozukluğu desteklemektedir.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Fenilalanin hidroksilaz aktivitesinde azalma en tutarlı yanıttır.

Kanıt 1: Yenidoğan taramasında fenilalanin yüksek bulunmuştur.

Kanıt 2: Akraba evliliği otozomal resesif metabolik hastalık olasılığını artırmaktadır.

Kanıt 3: Tirozin düzeyinin düşük-normal olması dönüşüm basamağındaki bozukluğu desteklemektedir.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıttan ayrılır.

Exam Pearl: Fenilketonüride erken diyet tedavisi zekâ geriliğini önlemenin temel yoludur.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok

VAKA 410: v339-peds-010-erken-meme-gelisimi

Başlık: Erken meme gelişimi

Branş: pediatrics | İlgili Branş: Pediatri / Endokrinoloji | Vaka tipi: standard | Zorluk: Zor

Klinik Hedef: Klinik bulgular ve tetkik verileriyle olası tanıyı belirleme.

Learning Target: Santral puberte prekoksü erken pubertal gelişim, ileri kemik yaşı ve pubertal LH yanıtıyla tanıyabilme

Klinik Senaryo / Hasta Bilgisi

Çocuk, son aylarda belirginleşen meme gelişimi, hızlı boy uzaması ve pubik kıllanma nedeniyle getiriliyor. Ailesi son 8 ayda çocuğun kıyafetlerinin hızla küçüldüğünü, vücut kokusunun değiştiğini ve meme gelişiminin giderek arttığını belirtmektedir. Vajinal kanama olmamıştır. Topikal hormon kremi veya ilaç maruziyeti öyküsü yoktur.

Demografi: 6 yaşında kız çocuk | Setting: Çocuk polikliniği

Vital Bulgular

Bu bölümde kayıtlı vital bulgu yok.

Fizik Muayene

- Tanner evre 3 meme gelişimi ve Tanner evre 2 pubik kıllanma vardır.
- Boy yaşitlarına göre üst persentilededir.
- Nörolojik muayene doğaldır, görme alanı kusuru saptanmaz.
- Ciltte café-au-lait lekesi yoktur.

Objektif Veriler / Tetkikler

Tetkik 1: Kemik yaşı grafisi

Etiket: Kemik yaşı grafisi | Tip: lab | Alt tip: Laboratuvar | Özet: Takvim yaşına göre belirgin ileri saptandı. | Klinik anlam: Hızlanmış seks steroid etkisini destekler. | Sonuç başlığı: Kemik yaşı grafisi | Sonuç özeti: Takvim yaşına göre belirgin ileri saptandı. | Yorum: Hızlanmış seks steroid etkisini destekler. | Satırlar: Kemik yaşı grafisi / 8.5 yaş / Takvim yaşı 6 yaş

Tetkik 2: GnRH uyarı testi

Etiket: GnRH uyarı testi | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Pubertal LH yanıtı saptandı. | Klinik anlam: GnRH bağımlı puberteyi destekler. | Sonuç başlığı: GnRH uyarı testi | Sonuç özeti: Pubertal LH yanıtı saptandı. | Yorum: GnRH bağımlı puberteyi destekler.

Tetkik 3: Pelvik ultrasonografi

Etiket: Pelvik ultrasonografi | Tip: imaging | Alt tip: Tetkik | Özet: Uterus boyutu ve over hacmi pubertal aktiviteyle uyumlu bulundu. | Klinik anlam: Östrojen etkisini destekler. | Sonuç başlığı: Pelvik ultrasonografi | Sonuç özeti: Uterus boyutu ve over hacmi pubertal aktiviteyle uyumlu bulundu. | Yorum: Östrojen etkisini destekler.

Görseller

Bu vaka için bağlı görsel URL/path kaydı yok.

Soru / Seçenekler / Feedback

Soru: Bu çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prematür telarş
B) Prematür adrenarş
C) Periferik puberte prekoks
D) McCune-Albright sendromu
E) Santral puberte prekoks

Doğru Cevap: Santral puberte prekoks

- A) Prematür telarş: Prematür telarş izole meme gelişimidir; büyüme hızlanması, ileri kemik yaşı ve pubertal LH yanıtı beklenmez. Bu olguda “Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.” ve “Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.” ipuçları tanısız karar açısından Santral puberte prekoks seçeneğini daha güçlü kılar.
- B) Prematür adrenarş: Prematür adrenarş izole pubik/aksiller kıllanma ve vücut kokusuyla seyreder; ilerleyici meme gelişimi ve pubertal LH yanıtı olmaz. Bu olguda “Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.” ve “Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.” ipuçları tanısız karar açısından Santral puberte prekoks seçeneğini daha güçlü kılar.
- C) Periferik puberte prekoks: Periferik puberte prekoks GnRH bağımsız seks steroid üretimiyle ilişkilidir; pubertal LH yanıtı santral aktivasyonu desteklediği için daha az uygundur. Bu olguda “Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.” ve “Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.” ipuçları tanısız karar açısından Santral puberte prekoks seçeneğini daha güçlü kılar.
- D) McCune-Albright sendromu: McCune-Albright sendromunda café-au-lait lekeleri ve periferik otonom hormon üretimi beklenebilir; bu olguda café-au-lait yok ve LH yanıtı santraldir. Bu olguda “Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.” ve “Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.” ipuçları tanısız karar açısından Santral puberte prekoks seçeneğini daha güçlü kılar.
- E) Santral puberte prekoks: Santral puberte prekoks ilerleyici pubertal bulgular, ileri kemik yaşı ve pubertal LH yanıtıyla en uyumlu tanıdır. Vakadaki “Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.” ve “Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.” ipuçları birlikte değerlendirildiğinde bu seçenek klinik olarak gerekçelenir.

Klinik Gerekçe / Kanıt / Core

Klinik gerekçe: Erken meme gelişimi olgusunda klinik karar tanısız karar üzerine kuruludur. “Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.” ve “Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.” birlikte okunduğunda Santral puberte prekoks seçeneği öne çıkar; “GnRH uyarı testinde pubertal LH yanıtı saptanmıştır.” ise ayırıcı kararın güvenilirliğini artırır.

Rationale: Sekiz yaşından önce ilerleyici meme gelişimi, büyüme hızlanması, ileri kemik yaşı, pubertal LH yanıtı ve pelvik organlarda östrojen etkisi santral puberte prekoksü düşündürür. Bu durum hipotalamo-hipofizer-gonadal aksın erken aktivasyonudur ve altta yatan santral nedenler açısından değerlendirme gerektirir. Bu olguda kararın temel ayrımı, “Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.”, “Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.” ve “GnRH uyarı testinde pubertal LH yanıtı saptanmıştır.” bulgularının aynı klinik mekanizmayı desteklemesidir; bu nedenle Santral puberte prekoks en tutarlı yanıtıdır.

Kanıt 1: Kız çocukta 6 yaşında ilerleyici meme gelişimi ve pubik kıllanma vardır.

Kanıt 2: Kemik yaşı takvim yaşına göre belirgin ileridir.

Kanıt 3: GnRH uyarı testinde pubertal LH yanıtı saptanmıştır.

Core Knowledge: Klinik karar sorularında tek bir ipucu yerine öykü, zamanlama, muayene ve objektif verilerin oluşturduğu patern birlikte değerlendirilmelidir. Çeldiriciler, benzer bulgu verebilse de lokalizasyon, şiddet, zamanlama veya yönetim önceliği açısından doğru yanıtıtan ayrılır.

Exam Pearl: Santral puberte prekoks GnRH bağımlıdır ve pubertal LH yanıtı ile desteklenir.

Kalite notu: ID korundu: Evet | Tek doğru cevap: Evet | Seçenek sayısı: 5 | Feedbackler tamam: Evet | Section bypass: Hayır | QC problem: Yok